

специфические противоядия, например, противоядие против мышьяка (см. в таблице — *Мышьяк*), тяжелых металлов (см. в таблице — *Ртуть*).

Симптоматическое лечение. Отравленные требуют самого внимательного наблюдения и ухода, чтобы во-время принять меры против угрожающих симптомов. При угнетении дыхательного центра для его возбуждения применяют холодные обливания затылка и шеи в теплой ванне, вдыхания кислорода в смеси с углекислотой (5—7%), инъекции атропина, камфоры, кофеина, стрихнина и лобелина.

Rp. Sol. Lobelini hydrochlorici 1% 1,0 D. t. d.
N. 6 in amp.
S. 1 мл под кожу

При явлениях сердечной недостаточности тоже применяют камфору, кофеин и стрихнин. При возбуждении нервной системы назначают успокаивающие и снотворные.

Rp. Infusi rad. Valerianae ex 6,0—200,0
Natrii bromati 8,0
Codeini phosphorici 0,2
MDS. По столовой ложке 3 раза в день Rp.

Bromurali 0,3
D. t. d. N. 3
S. По 1 порошку 2—3 раза в день Rp.

Luminali 0,1
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 порошку на ночь Rp.

Vcronali 0,5
D. t. d. N. 3
S. За час до сна 1 порошок в полстакане горячей воды

При судорогах — хлоралгидрат внутрь или в клизмах, а также вдыхания хлороформа.

Rp. Chlorali hydrati 1,0
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2 раза в день в молоко Rp.
Chlorali hydrati 2,0
Mucilaginis Salep
Aq. destill. aa f0,0
MDS. Для клизмы

При резких болях — морфин или омнопон подкожно.

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл 1—2 раза в сутки под кожу Rp.
Sol. Omnoponi 2% 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл 1—2 раза в сутки под кожу

В случае понижения температуры тела или похолодания конечностей больных укутывают теплыми одеялами, растирают, дают горячее питье, обкладывают грелками или бутылками с горячей водой.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДАМИ, НЕ ОПОЗНАННЫМИ ДО ПРИБЫТИЯ ВРАЧА

(Государственная Фармакопея СССР, VIII издание, 1946 г.)

При попадании яда на кожу — обмыть кожу большим количеством воды и положить на пострадавшие места повязку с глицериновой или спермацетовой мазью, с кольдкремом или вазелином.

При попадании яда в глаза — тщательно промыть их чистой водой; при болях в глазах накапать по 2—3 капли 1% раствора новокаина или дикаина в какадый глаз, после чего наложить повязку.

При отравлении через дыхательные пути — поместить больного в теплую комнату с чистым воздухом, промыть нос, рот и глотку водой или 2% раствором бикарбоната натрия; снять одежду, стесняющую дыхание и пропитанную ядовитым веществом. Давать вдыхать кислород или карбоген, производить искусственное дыхание в случае прекращения дыхания у больного или недостаточности дыхания.

При отравлении через рот — вызвать рвоту раздражением корня языка или задней стенки глотки. Тщательно промыть желудок чистой водой или водной взвесью активированного угля или жженой магнезии, или раствором перманганата калия, после чего дать или ввести в желудок раствор сульфата магния или натрия вместе с активированным углем. Кишечник промыть чистой водой с взвесью угля. Внутрь дать диуретин. Под кожу ввести глюкозу или хлорид натрия. При ослаблении сердца и дыхания — давать нюхать нашатырный спирт, под кожу — кофеин, камфору, коразол, лобелии. При сильных болях — под кожу ; орфин или омнопон; при коликах и схваткообразных болях в животе — грелки па живот, под кожу — атропин и папаверин; при судорогах — внутрь или в клизме хлоралгидрат.



*

CD

H
M
>
a
a
o
i
o
B

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Адонилен, адонизид Адонис Адrenalин, эфедрин	Возбуждение, сердцебиение, учащение пульса и дыхания, повышение кровяного давления, затем рвота, нитевидный пульс, отек легких	См. Наперстянка См. Наперстянка Полный покой, осторожно давать вдыхать амилнитрит (накапав 3—5 капель на вату или платок), 0,5—0,8 г хлоралгидрата в клизме. Подкожно — папаверин хлористоводородный 1—2мл 2% раствора. Кровопускание. Вдыхание кислорода
Азотная кислота	См. Кислоты. Желтая окраска слизистой рта. Рвота желтоватыми кровянистыми массами	См. Кислоты
Азотносеребряная соль	В тяжелых случаях коллапс и потеря сознания.	См. Нитрат серебра
Акация желтая, ракитник или золотой дождь — <i>Cytisus laburnum</i> ; Цитизин	Кома—слабость, тошнота, рвота, иногда с кровью, понос, боли в животе. Холодный пот, судороги, бред, галлюцинации, коллапс	Промывание желудка взвесью угля с водой. Внутрь — солевое слабительное. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитал. Согревание тела. Полный покой
Аконит, аконитин		См. Борец
Акрихин	* Желтое окрашивание кожных покровов. Боли в животе, иногда рвота. Кожный зуд. Головная боль, бессонница, общая слабость. Возбуждение. Расстройство зрения, слепота	Промывание желудка раствором марганцовокислого калия 1: 4000 или 0,2—0,5% раствором танина. Внутрь — солевое слабительное. Обильное щелочное питье. Грелка на живот. Под кожу — кофеин, камфора. Затемненная комната. Постельный режим
Амитадин		См. Синильная кислота
Аналгин		См. Антипирин

22

Амилнитрит	Покраснение лица, шеи, груди, ощущение жара, чувство опьянения, головокружение, понижение артериального давления, падение температуры. Стеснение в груди, затрудненное дыхание. Расширение зрачков	Свежий воздух. При ослаблении или остановке дыхания — искусственное дыхание, вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — кофеин, камфора. При резкой метгемоглобинемии — кровопускание и переливание крови. Внутривенно — ■ глюкоза. Постельный режим
Аммиак		См. Нашатырный спирт
Анабазин	Слюнотечение, тошнота, рвота, понос, головокружение, дрожь, общая слабость, одышка. В тяжелых случаях холодный пот, бред, судороги, резкое угнетение дыхания •	При приеме внутрь: рвотное — апоморфин или сернокислая медь. Промывание желудка взвесью угля с водой. Внутрь — солевое слабительное. Вдыхание кислорода или карбогена. Подкожно или внутривенно — глюкоза. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитал. Полный покой. При попадании на кожу немедленно снять одежду и тщательно обмыть места поражения теплой водой, подкисленной лимонной или уксусной кислотой. Вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу или внутривенно — глюкоза. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитал. Полный покой
Анилин (анилиновые краски, антифебрин, нитробензол, толуидин, фен-ацетин)	Рвота, головокружение, шум в ушах, одышка, цианоз, слабый пульс (коллапс), судороги, кома	При вдыхании или всасывании через кожу — свежий воздух, вдыхание кислорода или карбогена. Искусственное дыхание. При резкой метгемоглобинемии — кровопускание с последующим переливанием крови. Внутривенно — глюкоза, адреналин. Под кожу — кофеин, камфора, коразол.
		При приеме внутрь: рвотное — апоморфин, сернокислая медь. Промывание желудка. Солевое слабительное. В остальном помощь, как при отравлении путем вдыхания. Противопоказано: внутрь — жир, масло, молоко, спирт, эфир

а
с
о
а¹³
ы
о
а
а
а
а
о
о
о
§
а
«у
а
у
о
о
а
н
а

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Анилиновые краски		См. Анилин
Антипирин, анальгин, пирамидон	Ослабление слуха, шум в ушах, расширение зрачков, тошнота, рвота, головная боль, понижение температуры тела, сонливость, судороги в и.рах, одышка, кома, иногда кожные сыпи	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка взвесью угля с водой. Внутрь — солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора, изотонический раствор хлористого натрия. При судорогах — внутрь хлоралгидрат. Согревание тела. Избегать жиров и алкоголя
Антифебрин		См. Анилин
Антифриз	Легкое опьянение. Сильная жажда. Боли в животе. Рвота, понос. Возбуждение. Затемненное сознание. Цианоз. Коллапс. В затянувшихся случаях поражение почек (анурия, уремия)	Промывание желудка. Слабительное. Кровапоускание. Обильное питье. Подкожные вливания физиологического раствора или 4,5% раствора глюкозы. Внутривенно 5% раствор двууглекислого натрия 500,0. При коллапсе — кофеин, камфора, стрихнин, кордиамин, коразол
Апоморфин	Тошнота, рвота. Падение сердечной деятельности, слабый аритмичный пульс. Возбуждение, коллапс	Поддерживать рвоту, давая внутрь большие количества теплого молока или слизистого отвара. Промывание желудка. Внутрь — водная взвесь угля, крепкий чай или крепкий кофе. 2% раствор танина по столовой ложке. Под кожу — кофеин, камфора, стрихнин. Постельный режим
Ареколин		См. Мускарин
Аррениал		См. Мышьяк
Аспирин		См. Салициловая кислота
Атоксил		См. Мышьяк
Атофан	Общая слабость, тошнота, рвота, болезненность живота, увеличенная болезненность печени, желтуха. Зуд и кожные сыпи. Бред, коллапс. Кома	Промывание желудка. Слабительные соли. Лечение острого гепатита (желтухи). Кимполон 2,0—4,0 ежедневно внутримышечно. При упадке сердечной деятельности кофеин, камфора и т. д.
Атропин, красавка — <i>Atropa belladonna</i> , белена, аэрон, гиосциамин, гоматропин, дурман, платифиллин	Сухость во рту и глотке, затрудненное дыхание, расширение зрачков, тошнота, рвота. Сухая кожа, покраснение лица, головная боль. Резкое учащение пульса, сильное возбуждение, бред, галлюцинации	Промывание желудка водной взвесью угля или раствором марганцовокислого калия 1:1 000 с последующим введением через зонд солевого слабительного. Покой. При резко выраженном возбуждении — клизму с хлоралгидратом. Под кожу — 1 мл 1% раствора хлористоводородного морфина, 1 мл 1% раствора хлористоводородного пиллокарпина повторно до исчезновения сухости во рту. Холод на голову. При резкой слабости — кофеин, камфора. Постельный режим
Ацесал		См. Салициловая кислота
Ацетилхолин хлорид		См. Мускарин
Аэрон		См. Атропин
Барбитамил		См. Веронал
Барий и его соединения — растворимые соли; барий едкий	Жжение во рту и пищеводе, тошнота, рвота, понос, боли в животе. Урежение сердечных сокращений, аритмия. Усиление тонуса гладкой мускулатуры, повышение артериального давления, судороги. Головокружение, расстройство зрения	Промывание желудка 1% раствором сернокислого натрия. Внутрь — раствор сернокислого натрия (20,0 : 200,0) по столовой ложке каждые 5 минут. Внутривенно — 10 мл 3% раствора сернокислого натрия. Под кожу — камфора, кофеин, кордиамин. При тахикардии — свеча с 0,2 г хинина
Безвременник осенний — <i>Colchicum autumnale</i> , его семена, колхицин		См. Колхицин
Белена — <i>Hyoscyamus niger</i>		См. Атропин
Белильная известь		См. Хлор

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Белладонна Бензин Бензол, бензин, керосин	При вдыхании паров головная боль, возбуждение, затем угнетение, кома, при употреблении внутрь — рвота, понос	См. Атропин См. Бензол При отравлении парами: свежий воздух, искусственное дыхание, вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — кофеин, камфора. Согревание тела. При отравлении через рот, кроме вышеуказанного, рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Касторовое масло. Внутрь черный кофе, горячее молоко
Бертолетова соль	Тошнота, рвота черно-зелеными массами. Понос, желтуха, боли в животе, зелено-фиолетовые пятна на коже, уменьшение мочи. Белок и кровь в моче. Моча красноватая или черная. Головная боль, сильная одышка, бред, потеря сознания, коллапс	Промывание желудка водной взвесью угля с последующим введением солевого слабительного. Обильное питье щелочных вод или 0,5—1% раствора двууглекислого натрия. Переливание крови после предварительного обильного (500—600 мл) кровопускания. Внутривенно — 10 мл 20% раствора гипосульфита натрия повторно. Вливание изотонического раствора хлористого натрия или глюкозы. При коллапсе под кожу — кофеин, камфора. Противопоказаны кислоты, лимоны, спирт
Бетанафтол Бледная поганка Борец — <i>Aconitum napellus</i> и другие виды; аконитин	Жжение во рту, рвота, понос, боли в животе. Приступ одышки. Падение сердечной деятельности, судороги. Затемненное сознание, бред. Поражение	См. Нафталин См. Поганка бледная Повторное промывание желудка водной взвесью угля, раствором 0,2% таннина или раствором марганцовокислого калия (1:1 000) с последующим введе-

Борная кислота	слуха и зрения, цианоз. Полиурия. Холодный пот Рвота и понос. Головные боли. Сыпь на коже, начинающаяся с лица. Упадок сердечной деятельности, коллапс	Внутрь — водная взвесь угля, крепкий чай или кофе, настойка строфанта. Под кожу — кофеин, камфора, атропин. Согревание тела, теплые ванны. Искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — жженая магнезия, известковая вода, белковая вода, молоко. Солевое слабительное. Под кожу — изотонический раствор хлористого натрия
Ботулизм Бром, бромная вода	При вдыхании паров брома: насморк, кашель, удушье, явления бронхита и бронхопневмонии, слезотечение, конъюнктивит. Слизистая рта и языка имеет коричневый цвет. При внутреннем приеме: ооли в животе, рвота, понос	См. Птомаины При отравлении парами — свежий воздух. Вдыхать водяные пары с небольшой примесью нашатырного спирта. Ингаляции содового раствора. Кислород. При отравлении через рот — промывание желудка 0,5% раствором тиосульфата натрия. Внутрь — белковая вода, щелочные воды, жженая магнезия с водой, крахмальный клейстер, молоко, лед кусочками. Снаружи обожженные места присыпать анестезином с тальком и смазать ланолином
Бромурал Вербатрин, вшивое семя — <i>Semen Sabadillae</i> ; протовератрин, чемерица — <i>Veratrum Lobelianum</i>	Жжение во рту, глотке и пищеводе. Слюнотечение, жажда, рвота, поносы, боли в животе. Бледность, дрожание, мышечная слабость. Падение сердечной деятельности, коллапс	См. Веронал Промывание желудка 0,2% раствором таннина или водной взвесью угля. Солевое слабительное. Глотать кусочки льда. Внутрь — таннин. Под кожу — кофеин, камфора. При коликах — опий, омнопон. Искусственное дыхание. При попадании препарата в нос, глаза, глотку и на другие слизистые оболочки — хорошо промыть их и смазать 2% раствором хлористоводородного кокаина или дикаина

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Веронал, бромурал, мединал, люминал, барбамил, малил, гексенал, сонбутал, пронаркон, ректон	Сонливость, потеря сознания, глубокий сон. Цианоз. Гиперемия лица. Падение артериального давления. Бред, коллапс	Повторное промывание желудка. Солевое слабительное. Повторно высокие клизмы. Внутрь — крепкий чай или кофе. Вдыхание кислорода или карбогена. Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора хлористого натрия. Под кожу — коразол или кордиамин, цититон или лобелии, кофеин, камфора. Искусственное дыхание. Горчичники на конечности. Согревание тела. Постельный режим
Веселящий газ		См. Закись азота
Вех ядовитый		См. Омег водяной
Висмут салициловокислый	Болезненность десен, черная кайма на зубах, стоматит, затрудненное глотание, слюнотечение, боли в животе, кал черного цвета, желтуха, опухание суставов, заболевание почек (некро-нефроз)	Промывание желудка водной взвесью угля или 0,2% раствором таннина. Внутрь — Antidotum metallorum (противоядие от металлов). Солевое слабительное. Внутривенно — тиосульфат натрия, глюкоза. Высокие клизмы. Полоскание рта
Вода горьких миндалей Газы взрывные	Головная боль, головокружение, общая слабость, одышка. Судороги, кома	См. Синильная кислота
Газы опасные, водяной газ, генераторный газ, светильный газ, угарный газ	См. Угарный газ	Свежий воздух, искусственное дыхание с кислородом или карбогеном. Под кожу — цититон или лобелии, камфора или коразол, кофеин. Внутрь — крепкий чай или кофе. Покой. Согревание тела
		Помощь, как при отравлении угарным газом. См. Угарный газ

Гваякол		См. Фенол
Гексенал		См. Веронал
Гексилрезорцин		См. Фенол
Героин		См. Морфин
Гидрохинон		См. Фенол
Гиосциамин		См. Атропин
Гистон-цинк-инсулин ,		См. Инсулин
Гитален		См. Наперстянка
Гоматропин		См. Атропин
Горицвет		См. Наперстянка
Горчица — Brassica nigra, Brassica juncea (семена), горчичная мука, эфирное горчичное масло	Боли в животе, рвота, понос. В моче белок, эритроциты и цилиндры. Упадок сердечной деятельности	Промывание желудка, солевые слабительные. Внутрь — повторно 5—8 капель нашатырного спирта с водой. Вдыхать пары воды с небольшим количеством нашатырного спирта. Пить слизистые отвары. Под кожу — кофеин, камфора, морфин или омнопон. При попадании эфирного горчичного масла на кожу — обмыть ее
Горчичное эфирное масло		См. Горчица
Горький миндаль	Рвота, поносы, боль в животе, слюнотечение, головная боль, общая слабость, медленный и ел; бый пульс одышка, кома	См. Синильная кислота
Грибы ядовитые		См. Поганка бледная, мускарин (мухомор), строчок
Двуокись серы		См. Сернистая кислота
Дигален-нео		См. Наперстянка

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Дигинорм		См. Наперстянка
Лигиталис		См. Наперстянка
Ликаин		См. Кокаин
Лионин		См. Морфин
Ливнетин		См. Кофеин
Лисульфат		См. Сульфаниламидные препараты
Лихлопамин		См. Хлоп
Ловесный спирт		См. Спирты
Ловман Datura stramonium		См. Атропин
Едкий барий		См. Барий и его соединения
Едкий натр		См. Щелочи едкие
Едкое кали		См. Щелочи едкие
Жавелева вода		См. Хлоп
Закись азота (веселящий газ)	• Шум в ушах, цианоз, потеря сознания, асфиксия, паралич дыхания	Длительное искусственное дыхание, вдыхание кислорода или карбогена. Внутривенно — глюкоза. Под кожу — цититон или лобелии, кофеин или ко-разол изотонический раствор хлопи-стого натрия под кожу
Зелень французская		См. Мышьяк

И
н
д
я
о
в

Змеиный яд	На месте укуса ощущается боль, жжение, отечность, краснота и припухлость. Тошнота, рвота, понос. Общая слабость, судороги, коллапс	Немедленно после укуса змеи — под кожу — впрыскивание поливалентной противозмеиной сыворотки (1 часть сыворотки растворить в 10 частях стерильной воды). При укусе в конечность туго перетянуть выше места укуса. Отсасывание яда из ранки кровососной банкой. Подкожное впрыскивание вокруг места укуса 2—3 мл 2—5% раствора марганцовокислого калия. Под кожу — изотонический раствор хлористого натрия, кофеин, камфора, стрихнин. Обильное питье горячего крепкого чая или кофе
Золотой дождь		См. Акация желтая
Известь негашеная	Ожоги (беловатая окраска) слизистой оболочки рта. Боли во рту, зеве, глотке, пищеводе. Затруднение глотания. Рвота кровавистая (бурыми массами). Боли в животе, понос, иногда с кровью. Моча щелочной реакции. Общая слабость, коллапс	Возможно раннее осторожное промывание желудка водой, подкисленной уксусной кислотой. Внутрь — 1% раствор лимонной или уксусной кислоты, молока, яичный белок. Под кожу — кофеин, камфора
Инсулин, гистон-цияк-инсулин, трипротамин-цинк-инсулин	Чувство голода, общая слабость, значительная потливость, дрожание конечностей и всего тела, учащение пульса, иногда коллапс	В легких случаях внутрь — 20—40 г сахара, 200 г белого хлеба; в тяжелых случаях внутривенно — 100—200 мл 10% раствора глюкозы или под кожу — 50—100 мл изотонического раствора глюкозы; в клизме ввести 50 мл 20% раствора глюкозы. Под кожу — адреналин, 1 мл питуитрина
Иод, настойка иода, раствор Люголя	Бурое окрашивание языка и слизистой рта, рвота бурыми или синими массами (если в содержимом желудка имеется крахмал), понос, головная боль, насморк, кожные сыпи. В тяжелых случаях отравления судороги, малый, учащенный пульс, коматозное состояние	При приеме внутрь — промывание желудка 0,5% раствором тиосульфата натрия или пить стаканами (2—3) 5% раствор тиосульфата натрия, жидкий крахмальный клейстер или мучной отвар, молоко, белковую воду, слизистые отвары. Внутрь — 20—30 г угля в водной взвеси, 20 г жженой магнезии. Пить щелочные воды. Под кожу — изотонический раствор глюкозы и 5%

а
ч
о
в
с
и
а
а
д
а
о
о
о
а
д
о
з
н
и
а
м
и

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Йодоформ	Головная боль, насморк, кожные сыпи, иногда рвота и понос. Ослабление сердца. Судороги, коллапс, кома	раствор тиосульфата натрия. При отравлении парами йода — свежий воздух. Ингаляции 5 % раствора тиосульфата натрия или распыленного 2% раствора двууглекислого натрия. Повторно промывать и прополаскивать нос, рот и глотку 2 % раствором двууглекислого натрия. При болях в глазах промыть чистой водой и ввести по 2—3 капли 2% раствора хлористоводородного кокаи- на или дикаина в каждый глаз Немедленно убрать йодоформную повязку или повязку или тампон. Внутривенно — 50—100 мл 5—20 % раствора тиосульфата натрия. Пить щелочные воды
Ипекакуана — <i>Cephaells Ipecacuanha</i> Эметин Какодилловый натрий Кали едкое Каломель	Рвота. Понос, иногда кровавый. Приступы одышки (астма). Упалок сердечной деятельности. Коллапс. Раздражение слизистых оболочек (кожные сыпи, конъюнктивит и др.) »	При рвоте — поддерживать ее питьем теплой воды и молока. Промывание желудка 0,2—0,5% раствором таннина или водной взвесью угля. Внутрь — слизистые супы, молоко, опий, лед кусочками, обильное питье, содовая или сельтерская вода. Подкожно — кофеин, камфора, глюкоза См. Мышьяк См. Щелочи См. Сулема
Камфора	Рвота, понос, боли в животе, бред, судороги, коматозное состояние	Рвотное. Промывание желудка. Внутрь — солевое слабительное. При судорогах — внутрь или в клизму хлоралгидрат или барбитал. При коме — но-
со	Кантаридин Карболовая кислота Карбохолин Керосин Киноварь Кислоты Кислота азотная Кислота борная Кислота карболовая Кислота муравьиная Кислота салициловая	феин. Растирание тела, горчичники на конечности. Покой, постельный режим. Набегать жиров и спиртных напитков См. Шпанские мушки См. Фенол См. Мускарин См. Бензол См. Сулема При отравлении через рот противопоказаны рвотные и прием внутрь углекислых щелочей. Возможно раннее и обильное промывание желудка водой. Внутрь — жженая магнезия (20,0—200,0), известковое молоко, яичный белок, слизистые отвары. Обожженную слизистую рта и глотки смазывать 2 % раствором кокаина или дикаина. Под кожу — морфин, кофеин, камфора, изотонический раствор хлористого натрия. Внутривенно — 10 мл 10% раствора хлористого кальция. Лед на живот. Ингаляция содовым раствором. Глотать лед кусочками. При попадании кислот на кожу смыть их большим количеством воды или водой с мылом, или известковой водой, или слабым (0,5—1 %) раствором щелочей См. Азотная кислота См. Борная кислота См. Фенол См. Муравьиная кислота См. Салициловая кислота

РВАЯ

а
9
в
га
ч
о
а
и
о
и
а
а
о
о
м
с
о
н
>
а
с
а
я
и

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Кислота серная Кислота синильная Кислота соляная Кислота трихлоруксусная Кислота уксусная и уксусная эссенция Кислота хромовая Кислота щавелевая	Ожоги слизистой рта черноватого цвета	См. Серная кислота См. Синильная кислота См. Соляная кислота См. Уксусная кислота См. Уксусная кислота См. Хромовая кислота Кроме вышеуказанного о кислотах (см. Кислоты), немедленно следует вводить еще внутрь 0,6—1,0 хлористого кальция, растворив его в полустакане воды; пить известковое молоко, известковую воду, взвесь мела в воде. Внутрь — уксуснокалиевая соль, диуретин. Внутривенно — глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия. Под кожу: кофеин, камфора, коразол См. Рциин См. Морфин При приеме внутрь—промывание желудка водной взвесью угля или раствором марганцовокислого калия (1:1 000). Внутрь — танин. Вдыхать амилнит-рит (3—4 капли на платок) или внутрь нитроглицерин (по 2—3 капли 2—3 раза). При возбуждении и судорогах — хлоралгидрат 1,0—2,0 (избегать мор-
Клещевины семена Кодеин Кокаин, дикаин, совкаин, тиокаин, новокаин	Бледность, головная боль, головокружение, холодный пот. Расширение зрачков. Частый и слабый пульс. Рвота, боли в Животе. Судороги, бред, галлюцинации, коллапс	При приеме внутрь—промывание желудка водной взвесью угля или раствором марганцовокислого калия (1:1 000). Внутрь — танин. Вдыхать амилнит-рит (3—4 капли на платок) или внутрь нитроглицерин (по 2—3 капли 2—3 раза). При возбуждении и судорогах — хлоралгидрат 1,0—2,0 (избегать мор-
Колбасный ял Колларгол Колоцинта плоды — Fructus Colo-cynthidis, колоцинтин, подофиллин, эвфорбий Колхицин, семена осеннего зимовника, безвременника — Colchicum autumnale	Рвота, кровавый понос, судороги икроножных мышц, общая слабость. Упадок сердечной деятельности, коллапс Жжение в зеве и глотке, резкие боли в животе, рвота, понос рисовидными и кровавыми испражнениями. Жажда. Удушье. Малый неправильный, замедленный пульс. Цианоз. Коллапс. Иногда желтуха. Головокружение. Бред, судороги, общий паралич. Олигурия, гематурия	фина). Осторожно вдыхать хлороформ. Кровопускание с последующим влиянием изотонического раствора хлористого натрия. Согревание. Горячий кофе, вино. Под кожу — кофеин, камфора. Искусственное дыхание. Кислород. При подкожном введении, кроме вышеуказанного, перетягивание конечности выше места введения, но не до исчезновения пульса См. Птомаины См. Флаваргин Промывание желудка. Внутрь—уголь, слизистое питье, крепкий чай. Подкожно или внутривенно — изотонические растворы хлористого натрия и глюкозы. Внутрь — по 1 г основной азотновисмусовой соли 4—6 раз в день. Внутрь — коразол, дигинорм. Постельный режим Промывание желудка. Внутрь —15—20 г угля в водной взвеси. Промывание желудка 0,2 % раствором танина или водной взвесью угля. Солевое слабительное. Обильное питье крепкого чая, молока, слизистых отваров. При болях в животе —10 капель опийной настойки или морфин, омнопожа под кожу. Под кож} — кофеин, камфора, 100 мл изотонического раствора хлористого натрия. Укутывание, согревание тела См. Наперстянка См. Наперстянка См. Омег пятнистый Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь или в клизме — хлоралгидрат или барбамил. Под ко-
Конвазид Конвален Кониин Коразол	Эпилептиформные судороги, топические и клинические. Бледность лица, расширенные зрачки, дрожание, резкое возбуждение. Кома	См. Наперстянка См. Наперстянка См. Омег пятнистый Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь или в клизме — хлоралгидрат или барбамил. Под ко-

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении	
Кордиамин		жу — морфин. Покой. Внутривенно — глюкоза. Постельный режим	Н И Ч Ы > д а р к о в
Кофеин (кофе, чай), диуретин	Сердцебиение, головокружение, шум в уш их. Слабый учащенный пульс. Дреж жение, судороги. Галлюцинации, расстройство психики, коллапс	Меры помогли, как при отравлении коразолом. См. Коразол	
Красавка		Промывание желудка 0,2% раствором таннина. Внутрь — хлоралгидрат или барбитал, уголь, солевые слабительные. Вдыхать амилнитрит или внутрь — нитроглицерин. Теплые ванны. Искусственное дыхание	
Краски медные		См. Атропин См.	
Краски свинцовые, свинцовые белила		Сульфат меди См.	
Крезол		Свинец	
Кремнефтористый натрий		См. Фенол	
Креозот		См. Фтористый натрий	
Креолин		См. Фенол	
Крепкая водка		См. Фенол	
Кукольвана семена		Меры помощи, как при отравлении серной, азотной кислотой ■	
Лавровишневая вода		См. Пикротоксин	
Ландыш Лизол		См. Синильная кислота	
		См. Наперстянка	
		См. Фенол	
Лобелии	Сходны с симптомами при отравлении табаком. Рвота без поноса	Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь. Внутривенно — изотонический раствор хлористого натрия или глюкозы. При остановке дыхания — искусственное дыхание с кислородом или карбогеном. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитал. Полный покой	В о в ю о д В д В о о о о В д о н о о в а и
Люголя раствор		См. Иод	
Люминал		См. Веронал	
Ляпис		См. Нитрат серебра	
*	Ожоги пищеварительного тракта. Рвота (кровавая). Иногда понос. При полосканиях и спринцеваниях слишком крепкими растворами — воспаление и отек слизистых оболочек	См. Веронал	
Мэлил		Промывание желудка. Касторовое масло. Обильное питье, слизистые отвары, белковая вода. Внутрь таннин, уголь. Лед на живот. При упадке сердечной деятельности кофеин, камфора и др.	
Марганцовокислый калий		См. Спорынья	
		См. Веронал	
		См. Сульфат меди	
		См. Сульфат меди	
Маточные рожки	Медный вкус во рту, слюнотечение, рвота сине-зелеными массами, кровавый понос, тенезмы. Сильная жажда, рези, боли в животе. Головная боль, мышечная слабость, бред, судороги. Затрудненное дыхание, малый, неправильный пульс, коллапс. Уменьшение мочи, моча черного цвета, много белка		
Мединал Медные краски Медный купорос			
Меркузал		См. Сулема	
Метиловый спирт		См. Спирты	

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении	
Метиловый эфир салициловой кислоты Миарсенол Миндаль горький Можжевельное эфирное масло казачьего можжевельника Можжевельные ягоды казацкого можжевельника Juniperus Sabina, можжевельное эфирное масло Молочая сок Моносефт Морфин, его соли, кодеин, нарцеин, дионин, героин, опиум, омнопон	Жжение в глотке и желудке. Рвота, понос, иногда кровавый. Рвотные массы с запахом можжевельника. Учащенное мочеиспускание. В моче белок и кровь. Маточные кровотечения, у беременных выкидыш. Резкая болезненность живота. Судороги, бессознательное состояние, кома Сонливость, головокружение, шум в ушах, рвота, пульс и дыхание замедлены, пульс слабого наполнения, дыхание прерывистое (чейн-стоксово), температура тела понижена. Зрачки сужены. Сухость во рту. Постепенно усиливающаяся сонливость, цианоз, судороги, иногда коматозное состояние	См. Салициловая кислота См. Новарсенол См. Синильная кислота См. Можжевельные ягоды казацкого можжевельника Рвотное — апоморфин, серноокислая медь или серноокислый цинк. Промывание желудка. Высокие клизмы. Солевые слабительные. Обильное питье слизистых отваров. Жаров не давать. Мочегонные средства. Под кожу — кофеин, камфора или коразол, глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия См. Эвфорбий См. Сулема Повторное промывание желудка (даже после подкожного применения) водной взвесью угля, раствором марганцовокислого калия 1 : 1 000, 0,2% раствором танина. Под кожу — атропин повторно. Внутрь — солевое слабительное. Кровапускание с последующим введением изотонического раствора хлористого натрия. Вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — цититон или лобелии, кофеин, коразол или камфора. Длительное искусственное дыхание. Теплые клизмы с раствором	а н в а а о В о В d
Муравьиная кислота Мускарин, мухомор — Agaricus muscarius, ареколин, хлорид, карбохалин Мухомор Мыло зеленое Мышьяк, белый мышьяк или мышьяковистая кислота (ее ангидрид), мышьяковая кислота и их соли. Фовлеров раствор, какадилат натрия, арренал, французская зелень, атоксил Мышьяковистый водород	Жажда, слюнотечение, тошнота, рвота, понос, иногда кровавый, резкие боли в животе. Ослабленный, замедленный пульс. Затрудненное дыхание. Похолодание конечностей. Пот. Головокружение, затемнение сознания, галлюцинации. Сужение зрачков. Расстройство зрения, слепота. Коллапс, отек легких, судороги. Кома Жгучая боль в зеве, резкие боли в пищеводе и желудке. Рвота, сильная жажда. Холероподобный понос (испражнения вида рисового отвара), сильные боли в животе. Холодная потная кожа. Резкая бледность и цианозность. Малый, частый пульс, учащенное дыхание. Судороги, резкие боли в конечностях, потер), сознания, кома При больших дозах концентрации газа в окружающем воздухе внезапная смерть. Общая слабость, головокружение, головная боль, рвота, часто с	уксуса. Лед на голову. Следить за мочевым пузырем — катетеризация. Покой. Постельный режим. Против опоясывающих рвотных См. Кислоты — помощь, как при отравлении серной кислотой При приеме внутрь рвотное — апоморфин. Под кожу — атропин. Промывание желудка водной взвесью угля. Солевые слабительные. Высокие клизмы. При явлениях коллапса — под кожу камфора, кофеин или коразол, цититон или лобелии. Вдыхание" кислорода или карбогена. При сильном возбуждении внутрь или в клизме — хлоралгидрат или барбитал. На голову холодные компрессы. Противоопоясывающие внутри кислоты, лимоны, уксус См. Мускарин См. Щелочи едкие Обильное промывание желудка водной взвесью угля, раствором жженой магнезии (20,0 на 1 л воды). Внутрь — повторно через 5 минут давать по 1 чайной ложке противоядия от мышьяка (Antidotum arsenici) или противоядия от металлов (Antidotum metallo-rum) и жженую магнезию. Солевые слабительные. Молоко, масляные эмульсии. Согревание тела, на живот грелки. Под кожу — камфора, кофеин, адреналин. Внутривенно — глюкоза, тиосульфат натрия Внутривенно — адреналин, изотонические растворы глюкозы и хлористого натрия. Под кожу — кофеин или коразол. Промывание желудка водной	а о а ю о и и а а в б о о а а а о 1 и 3 н в з а х

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Мясной яд Наперстянка — <i>Digitalis purpurea</i> , <i>D. ambigua</i> , <i>D. ferruginea</i> , <i>D. lanata</i> . Дигален-нео, гитален, горицвет — <i>Adonis vernalis</i> , адонилен, адонизид. Ландыш — <i>Convallaria majalis</i> , конваллид, конвален, морской лук — <i>Bulbus Scillae</i> . Семя строфанта — <i>Semen Strophanti</i> ^	кровью, одышка, цианоз, желтуха. Боли в пояснице. Кровавая моча (гемоглобинурия). Коллапс. Потеря сознания, кома Вначале замедленный пульс. Общая слабость, похолодание конечностей, головная боль, рвота и понос, расширение зрачков. Затем учащение пульса, судороги, кома	взвесью угля. Согревание тела. Покой. Постельный режим См. Птомаины Полный покой. Постельный режим. Промывание желудка водной взвесью угля, 0,2—0,5% раствором таннина. Солевые слабительные. Под кожу — атропин, камфора, кофеин. Внутривенно — изотонический раствор хлористого натрия или 40 % раствор глюкозы. На кошу горчичники. При рвоте — глотание льда кусочками. Рвотных не давать Под кожу — кордиамин, цититон или лобелии, кофеин. Искусственное дыхание с кислородом или карбогеном. Внутривенно — глюкоза. Промывание прямой кишки
Нарколан	См. Веронал	См. Щелочи См. Салициловая кислота Обильное промывание желудка водной взвесью угля. Рвотное — апоморфин. Солевые слабительные. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно — глюкоза. Противопоказаны жиры» масла, алкоголь
Натр едкий Натрий салициловый Нафталин, нафтол, бетанафтол	Головная боль, тошнота, рвота, понос, боли в животе. В моче белок, кровь, цилиндры. Ослабление деятельности сердца	См. Нафталин Возможно раннее осторожное обильное промывание желудка (зонд хорошо
Нафтол Нашатырный спирт, аммиак	При вдыхании насморк, слезотечение, слюнотечение, мучительный кашель, потеря голоса, отек гортани, удушье, острый бронхит и пневмония; головокружение, обморок, похолодание конечностей, ослабление деятельности сердца; коллапс, кома. При приеме внутрь — ожоги полости рта, пищевода, желудка, рвота, часто кровавая; в тяжелых случаях — коллапс, кома. При поражении кожи и слизистых (глаза) — воспаление, ожоги	смазать маслом) водой или слабым раствором лимонной, виннокаменной или уксусной кислоты. Внутрь — 1/о раствор виннокаменной, уксусной или лимонной кислоты. Внутривенно или под кожу — изотонические растворы глюкозы или хлористого натрия. Морфин. При отравлении парами аммиака вдыхать теплые водяные пары или распыленный изотонический раствор хлористого натрия. Искусственное дыхание, сердечные средства
Неосальварсан		См. Новарсенол
Никотин Нитрат серебра (азотосеребряная соль, ляпис)	Белые или серые пятна на слизистой рта, темная кайма на деснах. Рвота белыми, чернеющими на свету массами. Позднее резкие боли в животе. Головная боль, головокружение, кожные сыпи. В тяжелых случаях — судороги, малый учащенный пульс. Коллапс, кома	См. Табак .. Промывание желудка 2% раствором хлористого натрия с последующим введением слабительного. Внутрь — 5 % раствор хлористого натрия по столовой ложке, каждые 10 минут. Белковая вода, молоко, масляные эмульсии, слизистые отвары. Клизмы из молока и хлористого натрия, масляные клизмы. Лед на живот. При сильных болях — морфин. Под кожу при коллапсе — кофеин, камфора
Нитрит натрия, нитроглицерин	Жжение в горле, головная боль, головокружение, краснота лица, рвота, понос, хриплое дыхание, замедленный слабый пульс, цианоз, возбуждение, бред, а затем потеря сознания, паралич	Свежий воздух. Промывание желудка. Солевые слабительные. При резкой метгемоглобинемии — кровопускание с последующим переливанием крови. Введение в вену 1 % раствора метиленового синего 50 мл. Внутривенно — глюкоза. Искусственное дыхание с кислородом или карбогеном
Нитробензол Нитроглицерин Новарсенол, неосальварсан, миарсенол, сальварсан	Головная боль, рвота, понос, иногда кровавый. Бледность, цианоз, судоро-	См. Анилин См. Нитрит натрия Внутривенно 10 мл 0,5% раствором хлористого кальция, 15—40 мл 5%,

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Новокаин	ги, коматозное состояние, коллапс. Иногда лихорадка до 39—40°, покраснение лица, дерматиты (явления отравления иногда спустя 2—3 дня). Желтуха (через 1—3 месяца), острая дистрофия печени	раствора тиосульфата натрия, 20 мл 40 % раствора глюкозы. Лед на голову. Согревание тела. Внутрь — диуретин. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. При судорогах — хлоралгидрат или барбитал. Постельный режим
Окислы азота	См. Азотная кислота. Кислоты	См. Кокаин Помощь, как при отравлении парами соляной кислоты. См. Кислоты — Азотная кислота
Оксись свинца		См. Свинец
Оксись углерода		См. Угарный газ
Омег водяной или болотный, вех ядовитый — <i>Cicuta virosa</i> ,	Горький вкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе, головокружение, одышка, судороги, потеря сознания, бред, расширение зрачков. Смерть от паралича дыхательного центра	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь, солевое слабительное. Высокие клизмы. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно — глюкоза. При судорогах — вдыхание эфира или хлороформа (осторожно!), внутрь — хлоргидрат. При остановке дыхания ■ — искусственное дыхание
Омег пятнистый или болиголов — <i>Conium maculatum</i> , кониин	Жжение в гортани, тошнота, рвота, понос, боли в животе. Головокружение, судороги. Ослабление пульса, понижение температуры, обмороки, одышка. Общий паралич	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка 0,2 % раствором таннина или раствором марганцовокислого калия 1:1 000. Внутрь — уголь, солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора, коразол, стрихнин. Внутривенно — глюкоза. Свежий воздух. Теплое обертывание, ванны. Переливание крови. Искусственное дыхание
Омнопон Опий		См. Морфин
Пантоцид		См. Морфин
Пантопон		См. Хлор
Папоротник turn Filicis m его экстракт - arts aethereum	-Extrac-	См. Морфин
Парахлорфенол	Рвота, кровавый понос, боли в животе, учащение и ослабление пульса, повышение температуры тела, одышка, сужение зрачков, расстройство зрения, желтуха, судороги, кома	Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Постельный режим. Теплые ванны, грелки. При судорогах — хлоралгидрат или барбитал. Противопоказаны мопо.ко, касторовое масло и другие масла и жиры
Пикриновая кислота	См также Кислоты. Желтая окраска сыпь. Моча красного цвета	См. Фенол См. Кислоты
Пикртоксин, кукольван, или рыбы Egustus Cocculi	Боли по желудочно-кишечному тракту. Рвота, понос, иногда желтуха. Возбуждение, спутанность сознания, дрожание, судороги. Упадок сердечной деятельности. Смерть от паралича дыхательного центра	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь, солевое слабительное. Под кожу атропин. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитал. Кроваопускание с последующим внутривенным вливанием изотонического раствора глюкозы и хлористого натрия. Искусственное дыхание
Пилокарпин	Слюнотечение и потоотделение, рвота, понос, сужение зрачков, падение сердечной деятельности, коллапс	Промывание желудка водной взвесью угля. Под кожу — атропин через 10 минут повторно до 3 раз. Кофеин, камфора. Покой. Постельный режим. Согревание тела. Внутрь — диуретин. Искусственное дыхание
Пирамидон	Отек легких, угнетение психики. при беременности — выкидыш	См. Антипирин
Пирогаллол		См. Фенол

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Пирокатехин		См. Фенол
Пищевые отравления		См. Птомаины
Плазмоцид	Воль в подложечной области, иногда рвота. Чувствительность нервных стволов. Расстройство походки: пошатывание («походка пьяного»). Дрожание. Расстройство координации всей произвольной мускулатуры. Головная боль, головокружение, сонливость, состояние оглушения. Резкое понижение зрения. Поражение печени и почек	Полный покой. Постельный режим. Обильное питье щелочных вод. Крово- пускание с последующим влиянием изотонического раствора глюкозы по- вторно. Глюкоза в капельных клир-мах. Внутрь — настойка строфанта или адонисен. Теплые ванны. Под кожу — кофеин, камфора. При глазных симп- томах — ретробульбарные инъекции атропина. Затемненная комната
Платифиллин		См. Атропин
Поганка бледная — <i>Amanita phalloides</i> ; шампиньон ложный, весенний — <i>Amanita phalloides</i> var. <i>vernalis</i> ; шам- пиньон ложный желтый — <i>Amanita phalloides</i> <i>marpa</i>	Рвота, понос, боли в животе, общая слабость, головокружение, головная боль, бред, коматозное состояние. Упадок сердечной деятельности. Вос- паление почек, анурия	Рвотное — апоморфин. Промыва- ние желудка водной взвесью угля. Со- левого слабительное. Высокие клизмы. Крово- пускание с последующим вли- ванием изотонического раствора глю- козы. Под кожу — кофеин, коразол. Искусственное дыхание
Подофиллин		См. Колоцинта плоды
Поташ		См. Селитра калийная
Прозерин		См. Физостигмин
Пронаркон		См. Веронал
Протаргол		См. Флаварган
Птомаины, колбасный яд, рыбий яд, сырный яд	Рвота, понос, боли в животе. Голо- вокружение, головная боль, общая	Внутримышечно 50—100 мл специ- фической .противоботулиновой сыво-

табл. 10

	слабость. Расширение зрачков. В тя- желых случаях — расстройство глота- ния, птоз, коллапс -	ротки. Рвотное — апоморфин или сер- нокислая медь. Промывание желудка раствором марганцовокислого калия 1:1 000 или 0,2% раствором таннина, или водной взвесью угля. Промывание толстой кишки сифонными клизмами. Солевое слабительное. Внутрь — уголь, крепкий чай и кофе. Под кожу — ко- феин, камфора или коразол. Под кожу или внутривенно — глюкоза. Согревание тела. Постельный режим
Ракитник		См. Акация желтая
Рвотный камень и другие препараты сурьмы	Металлический вкус во рту. Жжение в глотке, пищеводе. Боль во рту и животе. Рвота, понос. Жажда, сильное отхаркивание. Слабый, частый пульс. Коллапс. Падение температуры. Холодный липкий пот. Голово- кружение, потеря сознания, судороги, кома. При попадании на кожу — дер- матит, экзематозные сыпи	Рвоту поддерживать питьем теплой воды, молока, слизистых отваров. Про- мывание желудка водной взвесью угля или 0,2 % раствором таннина. Внутрь — молоко, белковая пода, лед кусочками, настойка опия. Под кожу — кофеин, камфора. Солевое слабительное. На живот — грелка. Постельный режим. Согревание тела
Резорцин		См. Фенол
Ректон		См. Веронал
Риванол	Тошнота, рвота, понос, боли в животе. Головная боль, нервное возбуждение, ослабление деятельности сердца, малый частый пульс. Одышка	Промывание желудка изотоническим раствором хлористого натрия. Обильное питье моло- да и щелочных вод. Внутрь — диуретин, кофеин, камфора, цититон или лобелии. Искусственное дыхание с кислородом или карбогеном
Рицин, клещевины семена — <i>Semen Ricini</i>	Металлический вкус во рту, боль, жж- ние. Беловато-серый налет на слизистой рта и языке, а затем язвенный стоматит, слинотечение. Сильная рвота, слизисто- кровянистый понос, боли в животе. Пораж-ние почек, затем анурия, в моче белок, кровь, цилиндры. Уремия. Замедление пульса, судороги, холодный пот, коллапс,	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — слизистые отвары. Высокие клизмы. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Тепло на <i>Шивог</i> при сильных болях — под КОЖИ морфин. На голову — холодные компрессы. Постельный режим

и токсикологич. 30

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Сернистый ангидрид Сернистый газ Сероводород, клоачный газ	Головокружение, головная боль, общая слабость, обморок, одышка, специфический запах выдыхаемого воздуха, потеря обоняния. Тошнота, рвота, понос. Расширение зрачков, бессознательное состояние, цианоз, ослабление сердца, отек легких, судороги, кома, паралич дыхания. Внезапно может наступить смерть (через несколько секунд или минут)	выми ложками. Промывание слизистых оболочек тем же раствором. Под кожу — кофеин или коразол См. Сернистая кислота См. Сернистая кислота Свежий воздух. Искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — камфора или коразол. При явлениях отека легкого обильное кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора хлористого натрия или глюкозы. Переливание крови. Горчичники к икрам. Холодное обливание головы. Согревание тела
Сероуглерод	При вдыхании — головная боль, головокружение, специфический запах выдыхаемого воздуха. Состояние опьянения (возбуждение). Расстройство дыхания, походки, зрения, речи, сознания. В тяжелых случаях — рвота, коматозное состояние. После присма внутрь — тошнота, рвота, понос, малый частый пульс, цианоз, судороги, кома	Свежий воздух, искусственное дыхание с вдыханием кислорода или карбогена. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора глюкозы или хлористого натрия. Переливание крови. Если яд введен в желудок, то, кроме вышеуказанных мер помощи, промывание желудка водной взвесью угля. Под кожу — апоморфин См. Спирты
Сивушное масло Синильная кислота, горький миндаль, вода горьких м.шдалей, лавровишневая вода, цианид калия, цианид натрия, цианистый газ, цианистый водород, амигдалин,	Затрудненное замедленное дыхание, слабый и редкий пульс, паралич в глотке, стеснение в груди. Головокружение, судороги, потеря сознания, расширение зрачков. Слизистые обо-	При отравлении путем вдыхания — немедленно удалить больного из отравленной атмосферы. Съежий воздух. Вдыхание 0,3 мл амилнитрита, можно повторно. Внутривенно — 50 мл 1 %

В
н
из
а
о
о
В
сг

	лочки и кожа яркокрасные. Запах горького миндаля изо рта. При сильном отравлении внезапная смерть	раствора метиленового синего в 25 % растворе глюкозы. Через 25—40 секунд внутривенно — 50 мл 25 % раствора тиосульфата натрия. При приеме внутрь, кроме того, безотлагательное промывание желудка раствором марганцовокислого калия 1:1 000 или 1—3 % раствором перекиси водорода или 5% раствором тиосульфата натрия. Во всех случаях — вдыхание кислорода или карбогена, при необходимости — искусственное дыхание. Под кожу — цититон или лобелии, кофеин, камфора, адреналин
Скипидар, терпентинное масло	Воли в подложечной области (желудке). Рвота с запахом скипидара, иногда понос. Общая слабость, учащенный пульс. Упадок деятельности сердца. Усиленное мочеотделение, моча с запахом фиалок. При поражении почек — кровь и белок в моче	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь, слизистое питье, кусочками лед, солевое слабительное, не давать касторового масла. Под кожу — кофеин, коразол, морфин или омнопон
Скополамин		Промывание желудка 0,2% раствором таинина или водной взвесью угля. Солевое слабительное. Высокие клизмы. При галлюцинациях — холод на голову. При угнетении дыхания под кожу — кофеин, цититон или лобелии. Искусственное дыхание
Совкаин Соляная		См. Кокаин
кислота	См. также Кислоты. Ожоги слизистой рта черноватого цвета	См. Кислоты. При отравлении парами — свежий воздух, вдыхание распыленных водяных паров с примесью нашатырного спирта
Сонбутал		См. Веронал
Спирты, алкоголь винный, амиловый, древесный спирт (метиловый), сивушное масло	Состояние опьянения, покраснение лица, иногда бледность, запах алкоголя и пена изо рта, рвота, сужение зрачков (в тяжелых случаях расширение). Возбуждение, острый Сред,	Рвотное — апоморфин, серноокислая медь или сернокислый цинк. Промывание желудка теплой водой. При красноте лица — высокое положение головы, лед, Теплая ванна о

В
и
о
а
»
В
»
В
а
о
о
и
З
»
В
о
>
и
и
н
В
В
В
Х

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
растворимый, дисульфид, сульфазол, сульфидин, фталазол и др.	боль, сонливость, одышка, цианоз, бред. Различные кожные сыпи, дерматит. Лихорадка. Поражение печени, желтуха. Поражение почек: кровавая моча, олигурия, анурия, уремия, лейкопения, агранулоцитоз	водной взвесью угля. Внутрь — касторовое масло, обильное питье жидкостей, особенно щелочных вод. Капельные солевые клизмы. Внутривенно — 40 % раствор глюкозы в изотоническом растворе хлористого натрия. Под кожу — 0 мл 1 % раствора никотиновой кислоты 3 раза в день. Внутрь — настойка ландыша, диуретин, кофеин. При метгемоглобинемии — внутривенно раствор глюкозы. Вдыхание кислорода. Повторное переливание крови. Не давать спиртных напитков. При поражении печени — внутривенно 40 % раствор глюкозы и одновременно 10 единиц инсулина. Противопоказаны барбитураты (как снотворные)
Сульфат меди, медный купорос, серномедная соль и другие соли меди, медные краски	Симптомы острого отравления: тошнота, рвота, головная боль, тахикардия, судороги, падение сердечной деятельности, коматозное состояние. При хроническом отравлении у курьильщиков наблюдаются диспептические явления, сердцебиение, тахикардия, аритмия, явления стенокардии, повышенная возбудимость, головокружение, потливость, расстройство зрения, сухость зрачков	Применение Antidotum metallorum (см. Сулема). Рвоту поддерживать обильным питьем теплого молока, белковой воды, слизистых отваров. Промывание желудка 0,1% раствором щелочной кровяной соли или раствором марганцовокислого калия (1:1 000). Внутрь 1 % раствор марганцовокислого калия по 1 столовой ложке каждые 15 минут или жженая магнезия (30,0); 6-лковая вода, солевое слабительное. На живот — грелки. Под кожу — кофеин, стрихнин. При болях — морфин или омнопон. Противопоказаны кислоты, жиры и масла
Сульфидин		См. Сульфаниламидные препараты
Сурьма и ее препараты		См. Рвотный камень См.
Сырный яд		Птоманы
Табак — <i>Nicotiana rustica</i>	Медный вкус во рту, слюпотечение, рвота сине-зелеными массами, кровавый понос, тенезмы. Сильная жажда, резкие боли в животе. Головная боль, мышечная слабость, бред, судороги. Затрудненное дыхание, малый неправильный пульс, коллапс. Уменьшение мочи, моча черного цвета, много белка	При отравлении частями растения рвотное — апоморфин или сернокислая медь или сернокислый цинк. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — солевое слабительное. При отравлении никотином и при курении холодный компресс на голову, промывание желудка водной взвесью угля. И в том, и в другом случае отравления — под кожу дигален-нео или кон-вазид, атропин. На живот — согревающие компрессы, пить теплое молоко. При спазме сосудов — вдыхание амилнитрита. При судорогах — гексенал или барбитал внутримышечно. Раствор уксуснокислого натрия 10% 20—40 мл внутривенно
Термопсис — <i>Thermopsis lanceolata</i>	Рвота, может быть кровавый понос. Малый пульс, коллапс. Судороги. Накожные сыпи. Иногда приступы бронхиальной астмы	Рвоту поддерживать теплым молоком, белковой водой. Промывание желудка 0,2% раствором таннина или водной взвесью угля (повторно). При судорогах — внутрь хлоралгидрат. При общем угнетении под кожу — кофеин, камфора или коразол, изотонический раствор глюкозы или хлористого натрия. Согревание тела. Искусственное дыхание. Постельный режим
Терпентинное масло		См. Скипидар
Тетра этил свинец	Потеря аппетита, тошнота, рвота. Бледность кожных покровов. Падение температуры тела и артериального давления. Бессонница. Головная боль и головокружение. Галлюцинации слуховые и зрительные. Повышенная потливость. Резкое возбуждение, судороги. В хронических случаях — вялость, апатия, быстрая утомляемость, боли в нижних конечностях	Чистый воздух. Кислород. Согревание. При приеме яда внутрь — промывание желудка 0,5—1% раствором глауберовой или английской соли. Внутрь — английская соль как слабительное и обильное питье белковой воды, молока, слизистых отваров. Снотворные: веронал 0,5, люминал 0,3, хлоралгидрат внутрь или в клизме (2,0). При коллапсе — кофеин, камфора, кордиамин, коразол
Этиловая жидкость		

Я
д
а
а
о
сВ
а
к
и
а
аа
о
о
иs
oV
иH
a
a
x

8

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Тетрахлорметан Тиокаин Толуидин Трипротамин-цинк-инсулин Трихлоруксусная кислота Угар Угарный газ, окись углерода, светильный газ, угар, взрывные газы	Головная боль, шум в ушах, головокружение, общая слабость, одышка, сердцебиение, на коже красные пятна. Тошнота, иногда рвота. Дыхание и пульс замедлены. В тяжелых случаях судороги, кома	См. Углерод четыреххлористый См. Кокаин См. Анилин См. Инсулин См. Кислоты См. Угарный газ Свежий воздух. Длительное искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. Вдыхание нашатырного спирта. Лед на голову. Внутрь — кофе, крепкий чай. Под кожу — цитатой или лобелии, кофеин, глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия. Внутривенно — 50—100 мл 25 % раствора глюкозы. На конечности — горчичники или грелки. Постельный режим
Углерод четыреххлористый, тетрахлорметан	После вдыхания — раздражение дыхательных путей, бронхит. Легочные кровотечения. Головная боль, угнетенное состояние, сонливость, двигательные и чувствительные параличи. После приема внутрь — головная боль, рвота, желтуха, галлюцинации, острый бред, потеря сознания, кома. Ослабление деятельности сердца	При отравлении путем вдыхания — свежий воздух, под кожу — кофеин, коразол, лобелин. Внутривенно — глюкоза, хлористый кальций. Длительное искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. При отравлении путем проглатывания — немедленно внутрь сернокислую медь или под кожу апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — солевое слабительное, уголь. Кроме того, использовать все, что указано выше при отравлении путем вдыхания этого яда
Уксусная кислота Уксусная эссенция Укус змеи Фовлеров раствор Фенамин	Кровянистая рвота, серовато-белая окраска слизистой оболочки рта. Запах уксуса изо рта Тошнота, озноб, головокружение, возбуждение, бессонница, рвота, нитевидный пульс, отек легких	См. Кислоты См. Кислоты См. Змеиный яд См. Мышьяк Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора хлористого натрия. Внутрь — двууглекислый натрий. Внутривенно — 20 мл 40 % раствора глюкозы. Под кожу — омно-пон. Хлоралгидрат или барбитал внутрь или в клизме. Полный покой
Фенацетин Фенол, карболовая кислота, крезо-лы, лизол, креолин, параклорфенол, пирокатехин, резорцин, гидрохинон, пирогаллол, креозот, гваякол, гексил-резорцин	См. также Кислоты. Рвотные массы беловатого цвета. Запах карболовой кислоты изо рта. Общая слабость. Поражение почек: моча чернооливкового цвета. Судороги, коллапс, кома	См. Анилин Промывание желудка водной взвесью угля, жженой магнезией или тиосульфатом натрия (30,0 на 1 л воды) до исчезновения запаха фенола. Солевое слабительное. Внутрь — известковый сахар, известковая вода или жженая магнезия (20,0—200,0) — через 5 минут по 1 столовой ложке, кусочки льда, слизистое питье, белковая вода. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Согревание тела. Ингаляции содовым раствором. При сушении голосовой щели — трахеотомия. Интубация. Противопоказаны внутрь сливки, молоко, масло, жиры, спирт
Физостигмия. Эзерин. Прозерин	Беспокойство, головокружение, слабость и ригидность мышц. Слезотече-	Примечание. Жидкую карболовую кислоту удаляют с поверхности тела немедленно, смывая ее спиртом или вазелином или каким-либо жирным маслом Под кожу — немедленно атропин. Рвотное — апоморфин. Промывание же-

И
М
Ч
У
а

О
В

**Я
0
▶
SW
аи
на
ии
оо
ю
IS
1
S
OH
%и
U
Н
В
а**

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
Флаваргин, колларгол, эларгол, протаргол	См. Нитрат серебра	лудка раствором марганцовокислого калия (1:1 000), водной взвесью угля, раствором таннина (1:500). Внутрь — солевое слабительное, уголь. Под кожу — камфора, цититон или лобелии, кофеин. Искусственное дыхание. При судорогах — осторожное вдыхание хлороформа
Формалин (формальдегид)	При отравлении парами — насморк, кашель, слезотечение, головная боль, потеря сознания. При попадании (отравлении) внутрь — рвота, иногда с кровью, боль в животе, возбуждение, ослабление сердечной деятельности, цианоз, коматозное состояние	При вдыхании паров — свежий воздух. Вдыхать водяные пары с примесью нашатырного спирта. Под кожу — кофеин, камфора, цититон или лобелии. При приеме внутрь — промывание желудка разведенным 3 % раствором углекислого или уксуснокислого натрия. Солевое слабительное, высокие клизмы. Внутрь по 20 капель нашатырно-анисовых капель повторно или 15 % раствор уксуснокислого аммония столовыми ложками. По 1,0—2,0 мочевины через 2 часа. Белковая вода, яичный белок, молоко. Под кожу — кофеин, камфора
Фосфор	Сильные боли в животе, рвота, рвотные массы пахнут чесноком и светятся в темноте, кровавый понос, испражнения светятся в темноте, слабый пульс,	Частые повторения промывания желудка 0,1—0,5% раствором сернистой меди или 0,04%раствором марганцовокислого калия. Внутрь 1% рас-
Французская зелень Фталазол	коллапс, желтуха, возбуждение, сонливость, кома	твор сернистой меди через 5 минут по чайной ложке до наступления рвоты или 0,1 % раствор марганцовокислого калия по столовой ложке через 15 минут. Слизистые отвары, щелочные воды. Солевое слабительное. Постельный режим
Фтористоводородный газ	Раздражение слизистых оболочек — насморк, слезотечение, упорный кашель, бронхит, отек легких, ослабление сердца, коллапс	Примечание. При попадании на кожу кусочков фосфора смыть их водой, а на обожженные места наложить повязку, смоченную 5 % раствором сернистой меди или 5 % раствором двууглекислого натрия, чередуя эти примочки до прекращения боли. Противопоказаны яшры, масла, молоко) айда
Фтористый натрий, кремнефтористый натрий	Рвота, иногда с кровью, понос. Возбуждение. Парезы мышц, судороги, паралич дыхательного центра	См. Мышьяк
Хинин	Головная боль, боли в животе, понос, шум в ушах, ослабление слуха, расстройство зрения, иногда слепота, сонливость, цианоз, иногда кожные сыпи, возбуждение, судороги, кома; у беременных может быть выкидыш	См. Сульфаниламидные препараты
Хлор, хлорная вода, белильная или хлориновая известь, хлорноватистокислый натрий, жавелевая вода, хлор-	При вдыхании паров — ожог слизистых дыхательных путей: кашель, удушье, боли в груди и в глазах, сле-	Внутривенно — хлористый кальций и глюкоза. Под кожу — кофеин и коразол. Искусственное дыхание. Вдыхание карбогена
		Промывание желудка. Внутрь — солевое слабительное, известковая вода, слизистые отвары, белковая вода. Внутривенно хлористый кальций (повторно через 1—2 часа)
		Промывание желудка водной взвесью угля или 0,2—0,5 % раствором таннина. Внутрь—касторовое масло. Под кожу— кофеин, камфора. Теплые ванны с холодным обливанием. При судорогах — хлоралгидрат. При спазмах сосудов — вдыхать амилнитрит
		При отравлении путем вдыхания — удаление из отравленной атмосферы в лежачем положении. Согревание. Внут-

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении
ристыи водород, хлорамин, дихлор-амин Б, хлорацид, пантоцид	зотечение, общее возбуждение, цианоз, отек легких, ослабление сердца, коллапс. При приеме внутрь — рвота и боли в желудке, стеснение в груди, сильный судорожный кашель, одышка, кровавистая мокрота, спазм голосовой щели	тривенно — 5—10 мл 10% раствора хлористого кальция. Кровопускание (400—600 мл) с последующим введением внутривенно 40 % раствора глюкозы 100 мл. Вдыхание кислорода. Под кожу — камфора, кофеин. При раздражении глаз — промывание 2 % содовым раствором. Вдыхать теплые водяные пары с примесью нашатырного спирта. При сердечной слабости — настойка строфанта внутрь, строфантин внутривенно. Полный покой. Постельный режим. При приеме внутрь: промывание желудка 2 % раствором тиосульфата натрия и затем водой. Внутрь — 5—15 капель нашатырного спирта с водой, белковая вода, раствор соды, молоко. Рвотное — апоморфин, полный покой, постельный режим
Хлоралгидрат	Жжение по тракту пищевода и желудка, тошнота, рвота, иногда кровавая. Глубокий сон, напоминающий наркоз. Зрачки сужены. Цианоз. Упадок сердечной деятельности, коллапс, паралич дыхательного центра	Повторное промывание желудка. Солевое слабительное. Повторно высокие клизмы. Внутрь — крепкий чай или кофе. Под кожу — кофеин, камфора или коразол, стрихнин, пититон или лобелии. Внутривенно — глюкоза с адреналином. Искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или кар-богена. Постельный режим. Согревание тела
Хлорамин		См. Хлор
Хлорацид		См. Хлор
Хлориновая известь		См. Хлор
Хлорная вода		См. Хлор
ТО		
Хлороформ, хлорэтил, хлорэтон	При вдыхании хлороформа бледность покровов, малый, редкий пульс, прерывистое и ослабленное дыхание. Рвота. Уменьшение мочи. Сначала сушение, а затем расширение зрачков. Запах хлороформа изо рта. При приеме хлороформа внутрь рвота, кровавый понос, желтуха	При отравлении путем вдыхания — прекратить наркоз. Свежий воздух. Искусственное дыхание с вдыханием карбогена. Внутривенно — 2 л изотонического раствора хлористого натрия, подогретого до температуры тела. Согревание. Под кожу — кофеин, камфора. Массаж сердца. При приеме внутрь — промывание желудка. Солевое слабительное. Искусственное дыхание. Под кожу — атропин, адреналин, кофеин, камфора. Внутривенно — 20 мл 40 % раствора глюкозы, одновременно 5 единиц инсулина повторно
Хлорэтил		См. Хлороформ
Хлорэтон		См. Хлороформ
Хромовая кислота	См. также Кислоты. Красно-желтое окрашивание губ, рта и зева, рвота желтыми, кровавистыми или зелеными массами. Головокружение, одышка. Бессознательное состояние, иногда су дороги. При попадании в глаза — конъюнктивит, на кожу — абсцессы	См. Кислоты
Цианид калия		См. Синильная кислота
Цианид натрия		См. Синильная кислота
Цианистый водород		См. Синильная кислота
Цианистый газ		См. Синильная кислота
Цинк, сульфат цинка или цинковый купорос, цинковые белила, хлорид цинка и другие соли цинка	Рвота, понос, боли в животе. Учащенный слабый пульс, коллапс, судороги, кома. Слизистая рта покрыта белым налетом	Поддерживать рвоту питьем теплого молока и белковой воды. Промывание желудка 2% раствором двууглекислого натрия или 0,2% раствором таннина. Внутрь — щелочные воды, слизистые отвары, молоко, яичный белок, позднее опий. Солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно — глю-

Яды	Симптомы острого отравления	Помощь при отравлении	
Цитварное семя		коза, хлористый натрий. На живот — грелки или согревающие компрессы	Н н ч ю > а и о а о в т
Цитизин		См. Сантонин	
Чемерица		См. Акация желтая	
ЧилиОуха		См. Вератрин	
Шампиньон весенний		См. Стрихнин	
Шампиньон желтый		См. Поганка бледная	
Шпанские мушки — Cantharides или Lytta veicatoria. Кантаридин	Жгучая боль во рту и глотке. Ожоги полости рта, языка. Слюнотечение. Жажда. Затрудненное глотание. Рвота, иногда поносы, боли в животе. Головная боль. Острое поражение почек; боли в области почек, болезненное и учащенное мочеиспускание. В моче кровь и белок, олигурия. Раздражение наружных половых органов. Сонливость, бред, судороги. При наружном применении — ожоги кожи. Остальные явления те же, кроме поражения желудочно-кишечного тракта	Обильное промывание желудка. Рвотное — апоморфин. Солевое слабительное. Внутрь — слизистые отвары, белковая вода. При болях — глотать лед кусочками. Под кожу — морфин, омнопон, кофеин, коразол. Постельный режим. Противопоказано внутрь молоко, масла, жиры, эфир, кислоты	
Щавелевая кислота	См. также Кислоты. Бело-серая окраска языка и слизистой рта. Удушье, рвота кровавыми или бурными массами. Олигурия, анурия. Параличи, ослабление сердца, расширение зрачков. Коллапс, судороги	См. также Кислоты. Внутрь — препараты извести (известковая вода, хлористый кальций, мел, зубной порошок). Высокие клизмы с известковой водой	
Щелочи едкие, едкое кали, едкий натр, аммиак, нашатырный спирт, зеленое мыло	Ожог слизистой губ, рта, пищевода и желудка. Кровавая рвота и кровавый понос. Резкие боли во рту, глотке, пищеводе и животе. Слюнотечение, расстройство глотания. Сильная жажда. Поражение почек; моча щелочной реакции. Судороги, коллапс. Иногда отек гортани	Возможно раннее осторожное промывание желудка водой, подкисленной уксусной кислотой (зонд хорошо смазать маслом). Внутрь 1 % раствор виннокаменной, уксусной или лимонной кислоты, повторно столовыми ложками через 5 минут. Слизистое питье с прибавлением тех же кислот. Обильное питье молока, масляных эмульсий. При болях — глотать лед кусочками. Ингаляции соловым раствором. Под кожу — морфин или омнопон, кофеин, камфора или коразол. Постельный режим. При попадании щелочей на кожу смыть их водой, а на обожженные места положить примочку с 5 % раствором уксусной, лимонной или виннокаменной кислоты	а с о к в о и а а и о о и в в о с т < а м я а а х
Эвфорбий, сок молочая		См. Колоцинт	
Эзерин		См. Физостигмин	
Эларгол		См. Флаваргин	
Эметин		См. Ипекакуана	
Эрготоксин		См. Спорынья	
Этиловая жидкость		См. Тетраэтилсвинец	
Эфедрин		См. Адреналин	
Эфир	3 шах эфира изо рта. Сонливость, спячка, состояние наркоза. Полная потеря чувствительности. Багровая окраска лица. Понижение температуры тела. Сначала сужение, а затем расширение зрачков. Малый пульс. Расстройство дыхания, а затем паралич дыхательного центра. Иногда внезапный паралич сердца. После наркоза иногда бронхиты и пневмония	Свежий воздух. Вдыхание кислорода или карбогена. Искусственное дыхание. Под кожу — стрихнин, цититон или лобелия, кофеин, камфора, адреналин. Изотонический раствор глюкозы или хлористого натрия. При замедлении дыхания давать нюхать нашатырный спирт	

5. Ответственность за неправильное написание рецептов несет и врач, прописавший рецепт, и директор или главный врач соответствующего лечебно-профилактического учреждения.

ПРАВИЛА ВЫПИСКИ ЛЕКАРСТВ ФЕЛЬДШЕРАМИ И АКУШЕРКАМИ

(Из приказа по Наркомздраву СССР 4/X 1937 г. № 1025)

1. Фельдшера, заведующие самостоятельными медицинскими пунктами, имеют право при исполнении служебных обязанностей выписывать из аптек за своей подписью, с обозначением должности и медицинского звания и при соблюдении приказа по Наркомздраву СССР от 16/VIII 1937 г. № 686 «О прописывании рецептов врачами» все необходимые для пользования больных лекарства, в том числе также содержащие ядовитые и сильнодействующие вещества в дозах, не превышающих высшего приема,

2. Все прочие фельдшера и акушерки имеют право выписывать из аптек за своей подписью для оказания экстренной помощи лекарства, содержащие в своем составе только следующие вещества: 1) ляпис в растворе не свыше 1%, 2) кофеин и его соли, 3) раствор сулемы не свыше 1:1 000 (0,1%), 4) опийную настойку не более 5,0 на рецепт, 5) стиптицин, 6) медный купорос, 7) густой и жидкий экстракт спорыньи, 8) спорыньи, 9) таблетки сантонины, 10) ландышевую настойку, И) таблетки с содержанием кодеина не свыше 0,015.

ГЛАВА XVII

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

О ПРОПИСЫВАНИИ РЕЦЕПТОВ ВРАЧАМИ

(Из приказа Наркомздрава СССР от 16/VIII 1937 г. № 686)

1. Все рецепты должны быть написаны разборчиво и четко.
2. Кроме состава лекарства и количества ингредиентов, в рецептах должны быть указаны:
 - а) назначение и способ употребления лекарства;
 - б) инициалы и фамилия больного;
 - в) инициалы и фамилия врача (факсимиле);
 - г) адрес врача или номер телефона (если имеется);
 - д) штамп лечебного учреждения (если рецепт дается врачом лечебного учреждения);
 - е) на рецептах, предназначенных для детей в возрасте до 14 лет, должно быть написано: «Для ребенка лет»;
 - ж) рецепты, написанные не на бланке лечебного учреждения, в том числе и рецепты частнопрактикующих врачей, удостоверяются личной печатью врача;
 - з) сокращенное обозначение близких по наименованию ингредиентов, не позволяющее установить, какое именно средство прописано, не допускается; так, например, нельзя писать: «Ac. arse nic», а необходимо написать: «Acidum arsenicosum»;
 - и) при указании в рецепте способа употребления нельзя ограничиваться общими выражениями: «внутреннее», «употреблять, как сказано» и т. д., а необходимо указать время «приема и дозу (например, «3 раза в день по 1 столовой ложке до еды» и т. д.).
3. По неправильно написанному рецепту (неправильная дозировка, неразборчивость) лекарство не изготавливается. Врач, выдавший его, обязан немедленно написать другой рецепт. В случае отсутствия в этот момент в лечебном учреждении врача, написавшего данный рецепт, главный врач лечебного учреждения обязан обеспечить своевременное возобновление требуемого для больного рецепта. Одновременно аптека должна в специальной книге вести учет неправильно выданных рецептов. Вместе с тем копии таких рецептов должны направляться главному врачу лечебного учреждения, откуда эти рецепты поступили; в случае выдачи рецептов частнопрактикующими врачами копии их отсылаются в райздравотдел для принятия в отношении этих врачей соответствующих мер.
4. Главные врачи лечебных учреждений обязаны во всех случаях неправильного прописывания рецептов принимать необходимые меры воздействия (от устного предупреждения до передачи дела прокурору включительно).

Продолжение

ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ И СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИТЫХ
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

[Дозы обозначают прием внутрь (per os) и выражены либо в граммах, либо, где это
указано, в миллилитрах и каплях]¹

Название препарата

Название препарата	Высшие дозы	
	разовая	суточная
Acetylcholinum chloratum под ксжу		
Acidum arsenicosum		
» nicotinicum под ксжу		
Acidum hydrochloricum purum dilutum		
» pronarconl		
» rectoni		
» sonbutali		
» sulfuricum purum dilutum . . .	0,2	0,6
Acrichinum		
Adalinum	0.003	0.01
Adonileum	0.1	0.3
Adonisidum под кошу	20 капель	60 капель
Adrenalinum solum (1 : 1 000) под	0.5	1.0
ксжу	0.5	1.0
Adrenalomim под кошу	0.5	1.0
Aether	15 капель	45 капель
Amygdalinum	0.2	0.6
Amylium nilrosom (вдыхание)	1.0	2.0
Anaesthesinum	30 капель	60 капель
Analginum	1 мл	2 мл
Antifebrinum		
Antipyrinum	1 мл	—
Apomorphinum hydrochloricum	0.01	
» » под	20 капель	60 капель
кошу	0.02	0.06
Aqua Amygdalarum amararum	5 капель	30 капель
Arecolinum hydrobromicum	0.5	1.5
Argentum colloidal (Collargolum) в	1.0	3.0
вену	0.3	1.0
Argentum nitricum	1.0	3.0
Arrhenalum под кошу	0.01	—
Atropinum sulfuricum		
Barbamylum	0,005	—
Bijochinolum в мышцу	30 капель	60 капель
Bismuthum salicylicum basicum	0,0005	0,0015
Bromuralum		
Bulbus Scillae	0,25	0,5
CarbochoHnum	0.03	0.1
> под кошу	0.06	0.2
	0,001	0,003
	0,5	1,0
	3 мл	

¹ Приводится по Государственной фармакопее СССР, VIII издание.
Дополнительный тираж, 1952 г.

1.0	3.0
0.6	1.0
0.3	1.5
0,001	0,003
0,0005	0,001

Название препарата

Высшие дозы

разовая

суточная

Carboneum tetrachloratum	3 мл	3 мл
Chloralum hydratum	2,0	6,0
Chloroformium	0, 5 мл	1,0 мл
Cocainum hydrochloricum	0,03	0,03
Codeinum phosphoricum	0,1	0,3
» purum	0,05	0,2
Coffeinum	0,3	1,0
» natrio-benzoicum	0,5	2,0
» salicylicum	0,5	2,0
Convallenum под кошу	1 мл	2 мл
Convacidum в вену	0,5 мл	1 мл
» под кошу	1 мл	2 мл
Cordiaminum под кошу	1 мл	2 мл
» внутрь	30 капель	90 капель
Corazolium	0,1	0,3
Creosotum	10 капель	30 капель
Cuprum sulfuricum внутрь как рвотное	0,5	
Diethylamidum acidu nicotiniци solu		
tum	30 капель	90 капель
Diethylamidum acidu nicotiniци solu		
tum под кошу	1 мл	2 мл
Dicaicum под кошу	0,015	0,03
Digalen-neo	1 мл	3 мл
Diginormum	20 капель	80 капель
Dioninum	0,03	0,1 7,0 6,0
Disulfanum	2,0	0,1
Diuretinum	1,0	0,15
Fmetinum hydrochloricum под кошу	0,05	0,15
Ephedrinum hydrochloricum	0,05	0,15
Extractum Belladonnae siccum	0,05	0,3
» » spissum	0,05	
» Cannabis indicae	0,1	0,3 0,4 0,3
» Filicis maris aethereum	8,0	50 капель
» Hyoscyami siccum et spissum	0,1	
» Ipecacuanhae siccum	0,2	3 мл
» Opii siccum	0,05	1,0
» Secalis cornuti fluidum . .	25 капель	0,05
» » » pro		
» injectionibus (Ergotinum) под кошу	1 мл	0,8
Extractum Secalis cornuti spissum' . .	0,3	0,6
» Strychni	0,012	
Flavacridinum hydrochloricum , . . .	0,2	1,5
Folium Belladonnae	0,2	0,5
» Convallari*е majalis et Flos		1,2
Convallariae majalis		0,6
Folium Digitalis		1,0
» Hyoscyami	0,4	50 капель
» Stramonii	0,2	0,03 10,0 0,6
Fructus Colocynthidis	0,3	0,3 0,015
Gitalenum	25 капель	
Harminum hydrochloricum под кошу	0,01	
Herba Adonidis vernalis	0,8	
» Cannabis indicae	0,2	
» Thermopsisidis	0,1	
Heroinum	0,005	
Hexenalum в вену	1,0	

Продолжение

Название препарата	Высшие дозы	
	разовые	суточные
Hexylresorcinum.....	1,5	15 ■
Homatropinum hydrobromicum	0,001	0,003
Hydrargyrum bichloratum.....	0,02	0,06
» ■ bichloratum.....	0,02	0,06
» chloratura mite.....	0,6	1,8
» cyanatum n oxycyanatum.....	0,01	0,03
под кошу.....	0,02	0,06
Hydrargyrum salicylicum в мышцу . .	0,05	0,15
Hydrastininum chloratum.....	1 мл	4 мл
Infusum Ipecacuanhae concentratum . .	0,025	0,05
Isaphehinum.....	0,02	0,06
Jodum.....	3 капли	10 капель
liquor Kalii arsenicosi.....	0,01	0,02
Lobelimum hydrochloricum под кошу	0,3	0,9
Luminalum.....	0,2	0,4
Malitum.....	1,0	2,0
Medinalum.....	2 мл	
Mercusalum в мышцу.....	0,03	0,1
Morphinum hydrochloricum.....	0,6	
Myarsenolum в мышцу.....	0,1	
Narcolanum в прямую кишку на 1 кг веса больного.....	0,003	0,01
K atrium arsenicicum.....	0,06	0,2
» iakodylicum.....	0,3	1,0
> hitrosum.....	0,05	0,15
» " под кошу.....	4 капли	10 капель
Nitroglyceriniim solutum.....	2,0	7,0
Norsulfazolum.....	0,6	
Novarsenolum p вену.....	0,2	
Novocainum под кошу.....	0,03	0,1
Gianoponium.....	0,1	0,3
Opium.....	0,25	1,0
Osareolum ■ ■.....	0,1	0,2
Papaverinum hydrochloricum.....	5 мл	10 мл
Paraldehydum.....	5 мл	
Parathyroidinum под кошу.....	0,1	0,3..
Phenolum purum.....	2 капли	6 капель
» » liquefactum.....	0,001	0,003
Physostigminiim salicylicum.....	0,01	0,02
Pilocarpinum hydrochloricum под кошу	2 мл	4 мл
Pluitrinum под кошу.....		0,15
» siccum.....	0,03	0,06
Plasmocidum.....	0,01	0,03
Platyphyllinum bitartaricum.....	0,1	0,3
Podophyllinum.....	0,5	1,5
Pelvis Ipecacuanhae opriatus.....	0,5	1,5
Pyramidonum.....	0,1	0,4
Radix Ipecacuanhae как отхаркиваю щее.....	1,0	0,05
Radix Ipecacuanhae. внутрь как рвотное	0,05	0,15
Rivanolum.....	1,0 ■	3,0
fialipyrimum.....	0,1	0,3
Salsolinum hydrochloricum.....	0,1	0,4
Santoninum в.....	0,0005	0,0015
ScopolaiBimmi hydroMomicwn		

Продолжение

Название препарата	Высшие дозы	
	разовая	суточная
Secale cornutum.....	10 мл	5,0
Solutio pronarconi 10% в вену.....	5 мл	—
» rectoni 10% в прямую кишку.....	5 мл	
» sonbutali 10% в вену.....	0,01	0,01
Sovcainum в спинномозговой канал Stibio- Kalinm tartaricum как рвотное.....	0,1	0,3
Streptocidum album.....	2,0 ■	7,0
Strychninum nitricum.....	0,002	0,005
Styptonum под кошу.....	0,01	
Stypticinum.....	0,1	0,3
Sullaculum.....	2,0	7,0
Sulfazolum.....	2,0	7,0
Sulfidinum.....	2,0	7,0
Tabulettae Aeroni.....	2 таблетки	4 таблетки
Theophyllinum.....	0,3	1,0
Thiocainum под кошу.....	0,05	
Thymolum.....	0,5	3,0
Thyreoidinum liquidum.....	1 мл	2 мл
» siccum.....	0,3	1,0
Tinctura Aconiti.....	8 капель	20 капель
» Belladonnae.....	20 »	60 »
» Cannabis indicae.....	20 »	60 »
» Convallariae majalis	30 »	90 »
» Digitalis.....	20 »	80 »
» Jodi 10%.....	8 »	25 »
» » 5%.....	15 »	50 »
» Ipecacuanhae.....	15 »	30 »
» Opii simplex.....	20 »	50 »
» Stroplianthi.....	10 »	20 »
» Strychni.....	15 »	30 »
Trypaflavinum.....	0,2	0,8
Veronolum.....	0,75	1,5
Yatrenum.....	1,0	3,0
Zincum sulfuribum внутрь как рвотное	1,0	—

Примечания. 1. Высшие дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, указанные в списке, рассчитаны на взрослых людей, достигших 25-летнего возраста.

Для невозмущавших и для детей высшие дозы уменьшаются в зависимости от возраста приблизительно так: Для молодых людей 18 лет — •/« дозы для взрослых

детей 14
7
6

» » 2 » 1/4 » » »
» * I 1 года — 1/13 » » »
» * ДО 1 » — 1/14-1/21 » » »

2. Высшие дозы уменьшаются до $3U$ И $1/2$ дозы для взрослых также и для лиц старше 60 лет.

3. Если ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства прописаны в рецепте в дозе, превышающей указанную в списке, и притом не прописью и без восклицательного знака, то заведующий аптекой или его заместитель обязан снести с врачом словесно (можно по телефону) или письменно (в запечатанном конверте) и лишь после получения ответа отпустить прописанное лекарство в соответствующей дозировке.

В случае невозможности объясниться с врачом по той или иной причине заведующий аптекой или его заместитель отпускает прописанное средство в половине той дозы, которая указана в списке как высшая.

ДОЗИРОВКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ЛЕКАРСТВ

по О. Д. Соколовой-Пономаревой и В. П. Бисяриной

Название препарата	Терапевтические разовые дозы для детей						Краткая характеристика
	до 1 года	до 2 лет	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет	
Acesalum	От 0,3 до 0,5 на 1 год жизни в сутки						См. Natrium salicylicum
Acidum arsenicosum	—		0,0005	0,0008	0,001	0,001-0,0015	Назначается при упадке общего питания, заболеваниях крови, неврастении. Младшим детям — в порошках, старшим — в пилюлях, 1—2 раза в день
Acidum ascorbinicum (витамин С)	От 300 до 500 мг в сутки независимо от возраста						Назначается при острых и хронических инфекционных заболеваниях, дистрофиях, гиповитаминозе С, при склонности к кровотечениям. Назначается per os, подкожно, внутримышечно, внутривенно в 5—10% растворе, по 1—2 мл
Acidum nicotinicum	От 15 до 50 мг в сутки, при пеллагре до 200 мг независимо от возраста						Назначается при пеллагре, пеллагрических состояниях, при втянувшейся дизентерии, колитах, энтеритах, при кожных заболеваниях, безбелковых отеках, заболеваниях печени, сердца (период декомпенсации) — в порошках или в 1% растворе подкожно, внутримышечно, внутривенно
Acidum paraaminosalicylicum — ПААС	По 1 г на год жизни ребенка, но не больше 8 г в сутки						Применяется для лечения туберкулеза легких. Назначается внутрь в порошках
Adiurecrinum		0,01	0,015	0,02	0,025	0,025—0,03	Препарат задней доли гипофиза. Назначается при
Ammonium bromatum	0,1-0,1	0,2 0,05	0,25 0,1	0,3 0,15	0,4 0,2	0,5-0,75	лечения несахарного диабета как нюхательный порошок (вдыхание) 3—4 раза в день. Противопоказан при бронхиальной астме, заболеваниях дыхательных путей и придаточных полостей
Anaesthesinum	0,02—0,0					0,25-0,3	Успокаивающее, особенно при коклюше, прибавляется обычно к микстуре
	*	0,05 0,1	0,1 0,2 мл	0,15 0,3	0,2 0,4 мл	0,25-0,3	Обладает местным анестезирующим действием. Применяется внутрь в слизистых отварах, порошках, ректально в свечах, наружно. ^ мазях (10%)
Analginum: внутрь	0,05 0,1	мл		мл		0,5-0,6 мл	Назначается как болеутоляющее и жаропонижающее средство при болях различного происхождения — внутрь, парентерально 1—2 раза в день. Запивать бор-жомом или содовой водой. Противопоказан при заболеваниях печени, почек и язве желудка
50% раствор анальгина для инъекций	мл		0,2 мл		0,3 мл	0,3-0,6 мл	Смесь равных объемов адреналина и питуритина. Применяется при бронхиальной астме подкожно
Antiasthmocri-num		0,1 мл	15,0 0,2	0,25 мл			Назначается внутрь при поносах (редко) 2—3 раза в день, добавляется к молоку
Aqua calcis		10,0 0,1-	0,2	15,0 0,25	0,3 0,3	0,3—0,5	Назначается как жаропонижающее и болеутоляющее средство в порошках 2—3 раза в день
Aspirinum (Acidum ace-tylosalicyli-cum)	10,0	0,15		0,25		0,3-0,4	Применяется при артритах и как желчегонное. Назначается в порошках 2—3 раза в день. Запивать боржомом или содовой водой.
Atopnanum	0,05	0,1					

Продолжение

C

							Продолжение
Название препарата	Терапевтические разовые дозы для детей						Краткая характеристика препарата и наиболее целесообразный способ его назначения .
	до 1 года	до 2 лет	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет	
C amphora trita	0,01—0,02	0,025	0,03	0,04	0,05	0,06- 0,075	Применяется как средство, возбуждающее дыхательный и сосудодвигательный центр, при асфиксии различного происхождения, при недостаточности сердечно- сосудистой системы. Назначается в порошках 2—3 раза в день. Значительно более эффективно подкожное введение
Carbo Ligni pulveratus	1 чайная ложка	1 десерт- ная ложка	1 десерт- ная лож ; а	1 десерт- ная ложка	1 столо- вая ложка'	1 столо- вая ложка /	Назначается как адсорби- рующее средство в виде волной взвеси главным об- разом при отравлениях ал- калоидами и другими ядовитыми веществами
Carbo lenura	1,0-2,0	3,0	3,0	5,0	5,0	10,0 J	
Corazolium (Car- diazolum)	0,005—0,01 По 0,01 на	0,015	0,02	0,025	0,03	0,05	Применяется вместо камфоры и кофеина, назначает- ся в порошках 2—3 раза в день или в виде 10% водного раствора подкожно, внутримышечно и внутривенно (от 0,2 до 1 мл)
Chininum byd- rochloricum	каждый Месяц ЖПЗ- ни ребенка, но не более 0,1 в сутки	От 1 года до 10 лет по 0,1 на 15 лет по 1,0 в день					Средство для лечения и профилактики малярии. Назначается в порошках. Более широко используется с этой целью акрихин как средство, более
Cbolegonum		0,01-0,02	0,025- 0,03	0,03-0,05	0,1	0,15	0,2-0,25

Cordiarinum: внутрь	1-2 капли	2 капли	3-4 капли	5-6 капель	7 капель	8-14 капель	похождения). Назначается внутрь в течение 3 дней, в последующем с промежутками в 2—3 дня
для инъекции	0,1—0,15 мл	0,2 мл	0,25-0,3 мл	0,4 мл	0,5 мл	0,5-0,75 мл	
Creosotum carbonicum	Ч-3 капли		5 капель	7 капель		8—10 капель	Средство, близкое по действию к камфоре и кофеину. Применяется при остром коллапсе, асфиксии, расстройстве компенсации сердечно-сосудистой деятельности 3—4 раза в день
Cyitinum	0,1—0,15 мл	0,2 мл	0,25 мл	0,3 мл	0,5 мл	0,5 - 1 мл	Применяется как отхаркивающее и антисептическое средство при хроническом бронхите, туберкулезе легких и обильном выделении мокроты. Назначается 2—3 раза в день с рыбьим жиром, горячим молоком, Сахарным сиропом или медом
Diginormum		2 капли	3-4 капли	5—6 капель	7 капель	8-14 капель	Представляет собой 0,15% раствор цитизина. Действует подобно лобелину, но действие выражено значительно сильнее. Применяется подкожно, внутримышечно 2—4 раза в сутки
Diaethylstilbestrolum	1 капля	0,0002	0,0003—0,0004	0,0005-0,0006	0,0007	0,0008-0,001	Водно-спиртовая вытяжка листьев наперстянки. Показания см. Folium Digitalis
Dsullanum	Суточная доза 0,2-0,15 на 1 кг веса	0,25	0,3	0,4	0,5	0,5-0,75	Синтетический препарат. Применяется при гемофилии и галакторрее у кормящих матерей. Назначается внутрь или подкожно один раз в день или через день в течение 2—3 недель
Elixir pectoralis	1 капля		4-4 капли	5-6 капель	7 капель	8-14 капель	Применяется при бациллярной дизентерии, колитах, энтеритах и др. Назначается каждые 4—6 часов на протяжении 8—10 дней
							Применяется как отхаркивающее средство

О Ч А Н Я В М О Т И М Я Я А

О В А Л О К И И В Ч О Я О В А О Т Н

Продолжение

Название препарата	до 1 года	Терапевтические разовые дозы для					Краткая характеристика препарата и наиболее целесообразный способ его назначения	
		детей до 2 лет	4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет		
ЕисЫпишиш	По 0,015 на каждый месяц жизни ребенка, но не более 0,15 в сутки	От 1 года до 10 лет от 10 до 15 по 0,15 на лет по 1,5- каждый год жизни, -2,0 в сутки					Противомаларийное средство. Назначается в порошках	О
Ferratum Ferri iodati sirupus Ferri carbonicuni saccharatum	0,15-0,2 5-Ю капле 0,2—0,25	капель 0,3	капель 0,5	капель 0,5	капель 0,75	капель 1,0	Препараты железа применяют при острых и хронических анемиях. Назначают 3 раза в день до приема пищи	О
Ferrura glycerinophosphoricum	0,1—0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5		О
Ferrum lactleuin	0,1—0,2	0,25	0,3	0,5	0,6	0,75 — 1,0		О
Ferrum reductum	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4-0,5		О
Ferrum sulfuricum oxydulatum		0,0^	0,1	0,15	0,25	0,3		О
Folium Uvae ursi	0,1—0,15	0,2	0,2V	0,3	Ж>	0,4—0,5	Входит с углекислым калием в состав пилюль Бло (Pilulae Blandi)	О
							Дезинфицирующее и антисептическое средство при воспалительных процессах мочевого пузыря и мочевых путей. Применяют в виде отвара, 3—4 раза в день	О
Glucosum	Для-внутривенных инъекций применяется 20—40% раствор (10—25мл), для внутримышечных инъекций —5 — 10% раствор (40—50 мл), для подкожных инъекций—5% раствор (до 100—200 мл), 0»5	0,15 для клизм— 5% раствор	0,15	0,25			Назначается: 1) при тяжелых острых инфекционных заболеваниях (пневмония, тиф, дизентерия, скарлатина и др.); 2) при сепсисе; 3) при хронической сердечно-сосудистой недостаточности; 4) при остром и хроническом нефрите; 5) при интоксикации наркотиками, ртутью, мышьяком и др.	О
Guajacolum carbonicum	Г мл	1 мл чайной ложки	0,3-0,5 чайная ложка	1 десертная ложка			Назначается внутрь в порошках 2—3 раза в день при хронических воспалительных процессах дыхательных путей	О
Haematogenum	Не назначается						Препарат из дефибрированной крови рогатого скота в смеси с глицерином. Применяется при малокровии, упадке питания, общем истощении	О
Hepalonum (Campolonum)		10 капле	15 капле	20 капле			Концентрированный водный экстракт печени крупного рогатого скота в ампулах по 1 мл (соответствует по активности 5—10 г сырой печени) для внутримышечных инъекций. Применяется главным образом для лечения анемий, при расстройствах питания, паренхиматозных гепатитах, а также при циррозах печени и других заболеваниях в течение 10—15 дней	О
Uepatocrinum (Hepatinum)	8-Ю капель						Жидкий экстракт печени для лечения анемий. Выпускается во флаконах по 10 и 30 мл. 10 мл препарат соответствует 250 г свежей печени. Внутр имышечно вводится 1—2 мл	О

Название препарата	Терапевтические разовые дозы для детей						Краткая характеристика препарата и наиболее целесообразный способ его назначения
	до 1 года	до 2 лет	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет	
Hefephytinum	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,3-0,5	См. Phytlnum
Insulinum	1-2 единицы	1-3 единицы	4—6 единиц	6-8 единиц	8-Ю единиц	10-15 единиц	Применяется главным образом при лечении сахарного диабета и диабетической комы, а также при заболеваниях печени, гипотиреозах (одновременно, с введением глюкозы). Назначается подкожно или внутримышечно за 20—30 мин-
Kallum bromatum	0,05-0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,3-0,5	нут до еды Успокаивающее средство. Назначается при невралгии, истерии, хорея спазмофилии, эпилепсии в водном растворе 3—4 раза в день
Kalium jodatum	0,05	0,1	0»15	0,2	0,25	0,3	Назначается при астматическом бронхите в водном растворе 3 раза в день. При базедовой болезни назначается 0,25% раствор по 1/1 чайной ложки 2 раза в день
Liquor ammonii anisati	1-2 капли	2 капли	3-4 капли	5-6 капель	7 капель	8-15 капель	Отхаркивающее. Применяют как добавление к отхаркивающим микстурам и так же рег зе.
Liquor ferri albuminati	10—20 капель	25-3Л капель	1/1 чайной ЛОЖКИ	1/1, чайной ложки	1 чайная ложка	1 чайная или десертная ложка	См. также препараты железа
Magnesium sulfuricum	—	2,0	3,0-4,0	5,0-6,0	7,0	8,0—15,0	В указанных дозах назначается как слабительное в 1/1—1/1 стакана теплой воды. Применяется как желчегонное в 5—10% водном растворе чайными или
Magnesii pulvis cum Rheo Methyonum	0,25—0,3 0,001 — 0,0025	0,5-1,0 0,003	1,0 0,004	1,5 0,005	2,5 0,007	3,0-4,0 0,007-0,01	десертными ледячами 3—5 раз в день. При судорогах, спазмофилии применяется 25% раствор внутримышечно по 0,2 мл на 1 кг веса Слабительное средство
Natrium benzoicum	0,03-0,05	0,05	0,1	0,15 0,5	0,2	0,2-0,3 1,0-	Препарат витамина К. Назначается при геморрагических диатезах, кровотечениях, а также при нефритах, острых гепатитах, туберкулезе и др.
Natrium bicarbonicum	0,1-0,2	0,25	0,3		0,75	1,5	Применяется как отхаркивающее средство в микстурах
Natrium bromatum Natrium jodatum Natrium salicylicum	0,05—0,01 0,05 0,1—0,15	0,15 0,1 0,2	0,2 0,15 0,25	0,25 0,2 0,3	0,3 0,25 0,4	0,4-0,5 0,3 0,5	Применяется как отхаркивающее средство в микстурах
Natrium sulfuricum Norsulfazolum		2,0	1,0-4,0 0,3	1,5 мл	7,0	8,0-15,0	способствующее размягчению и отделению слизи, в виде полосканий, промываний, ингаляций, компрессов (0,5—2% растворы). Внутрь назначается при ацидозе (инфекции, интоксикации), гиперацидных гастритах, язвах желудка, двенадцатиперстной кишки
Oleum camphora-tum 10%	Суточная доза 0,1—0,2 на 1 кг веса 0,5—1 мл	0,25 1 мл	1,5 мл	5,0-6,0 0,4	0,5 2 мл	0,5-0,75 2—2,5 мл	См. Kalium bromatum См. Kalium jodatum Жаропонижающее и болеутоляющее средство. При ревматизме назначается по 0,5 на год жизни в сутки в порошках или микстуре

**VE
m
Я
O
U
is
H
B
H
O
F
M
B
M**

Й
О
8

О
Ы
К
У

■
М
К
К
О

т
о
о
В
В
У
О
А

Название препарата	Терапевтические разовые дозы для детей						Краткая характеристика препарата и наиболее целесообразный способ его назначения
	до 1 года	до 2 лет	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет	
Oleum jecoris Aselli	V.-1 чайная ложка	1 чайная ложка	* 1 десертная ложка	1 десертная ложка	1 столовая ложка	1 столовая ложка	Применяется при лечении рахита, квинной слепоты, анемии. Назначается как общеукрепляющее средство перед едой.
Oleum Ricini	1 чайная ложка	1 чайная ложка	1 десертная ложка	1 столовая ложка	1 столовая ложка	1 столовая ложка	Слабительное средство.
Oreolcrinum		0,05	«0,1	0,2	0,25	0,3—0,5	Назначается при гипогенитализме. Применяется в порошках или таблетках 3 раза в день.
Pancreatinum	0,1—0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	Применяется при острых и хронических расстройствах пищеварения и питания. Назначается в порошках (с углекислым кальцием) 3—4 раза в день после еды.
Parathyreocrinum S. Parathyrolainum	0,25-0,3 мл	0,5 мл	0,75 мл	1 мл	1,5 мл	2 мл	Применяется при спазмофилии, тетании, бронхитической астме, крапивнице и др. 1 мл=20 ЕД. Назначается подкожно 1—2 раза в день.
Penicillinum	Суточная доза от 5 000—10 000 до 20 000—30 000 единиц на 1 кг веса	От 30 000 до 60 000 единиц на инъекцию 2—4 раза в сутки					Назначается при сепсисе, евфулфамиловосстойчивых пневмониях, менингитах, абсцессе легких, эмпиеме плевры, фурункулезе, тонзиллите, эндокардитах, хроническом холецистите, септической скарлатине, и т. д. Вводится под кожу, в мышцу, в вену в течение 5—10 дней. Вводится также интравенозально, интраплеврально.
Pepsinum	0,05-0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,3-0,5	Применяется при острых и хронических расстройствах
Pertussin							вах питания и пищеварения. Назначается в 0,5—1% растворе разведенной соляной кислоты перед едой.
Phenacetinum	10-20 капель	1/4 чайной ложки	1 чайная ложка		1 десертная ложка	1 десертная ложка	Применяется при коклюше и бронхите.
Phthalinum			0,15				Назначается как жаропонижающее и болеутоляющее средство при гриппе, невралгиях, головных болях и т. д. в порошках 2—3 раза в день в сочетании с кофеином, пирамидоном и т. д.
Phthalinum		0,1	0,2				Слабительное средство; является составной частью пургена, не назначать при страданиях почек.
Phthalinum	0,025-0,05	0,05			0,1		Применяется при дизентерии, колитах, гастроэнтеритах и др. Назначается через 4 часа 6 раз в сутки в течение 7-10 дней.
Pnytinum		0,25	Суточная доза	0,3			Содержит до 23% органического фосфора. Назначается при упадке питания, анемии, невропатии в порошках, таблетках 2—3 раза в день.
Pilocarpinum Hydrochloricum	0,1—0,2 на 1 кг веса			0,2	0,25		Применяется в глазной практике (суживает зрачок, понижает внутриглазное давление, усиливает аккомодацию).
Pituitrinum siccum Pituitrinum «P»	0,1—0,2 мл		0,05-0,1	0,15		у, 6—1 мл	Питуитрин—препарат задней доли гипофиза. Применяют при паралитической задержке мочеиспускания, парезе кишечника, несахарном диабете, гипопитарном карликовом росте, гипопитарном ожирении, при бронхиальной астме в сочетании с адреналином. Назначается подкожно.
		Глазные капли — 0,5—1% водный раствор, 1—2 капли 2—3 раза в день					
		0,25 мл	0,3 мл	0,5 мл	0,6 мл		

Э
>
<РОО
в
Н
ОЯК
Н
О
И
М
Й
И
Я

 $0 \geq$

Латинское название	Доза	Условия хранения	Способ применения	Доза	Условия хранения	Способ применения
Sal. Carolinum factitium				0,3		1 десертная ложка 0,25
Salipyrinum	0,03-0,05	чайная ложка		1		2 мл
Salitropinum (Cylotropinum)	0,25—0,5 мл	1 мл	0,01			2,5—3 мл
		чайная ложка	чайная ложка	0,2		
Salolum	0,05-0,1	0,1		1,5		0,3-0,5
		0,5 мл				
Sanalbinum	0,05	0,1		мл		0,25-0,3
Santoninum	0,002—0,005	0,015-0,03				0,04-0,05
Sennae tnfusum compositum (Inf. Sennae compos.) Sinoesttolum		чанная ложка		0,2 0,25		десертная ложна столовая ложка
				0,15		
		0,1		0,25		

фекции
желудка
и кишеч-
ника (в
раствора См.
х)

Слабите
льное
um

средство.
Развести
в 1/1— 1
стакане
теплой
воды и
принять
натошак

Жаропо-
нижающе
е и боле-
утоляюще
е
средство.
На-
значается
в
порошках
2—3 раза
в день

Водный
раствор
уротро-
пина (4
0%),
салицилов
о-
кислого
натрия
(16%)
ико-
феинсали-
циловонат-
риевой
солд(4%).
Применяе-
тся при
воспалите-
льных
процессах
в
мочеполо-
вых
путях,
при
энцефали-
тах
внутримы-
шечно,
внутри-
венно
один раз в
день или
через
день

Антисе-
птическое
средство
для
кишечник
а и
мочевых
путей
(цистит,
пиэлит).
На-
значается
в
порошках
3 раза в
день

Примен-
яется при
острых
энтерокол-
итах,
интоксика-
ционных
и
гастроген-
ных по-
носах.
Назначает-
ся в по-
рошках
3—5 раз в
день

Глистог-
онное
средство.
Применяе-
тся
против
аскарид,
остриц.
Назначает-
ся 2 дня
подряд с
промежут-
ками в
1—2 часа

Слабите
льное
средств

И О

а

О

Я

Й Н

О О

В О

» О

W

> О

13 В

-3

to

03

подкожно,

Продолжение

Название препарата	Терапевтические разовые дозы для детей					Краткая характеристика препарата и наиболее целесообразный способ его назначения		
	до 1 года	3—4 года и 5—6 лет		7 лет	8—14 лет			
Sulfazinum	Суточная доза 0,1—0,2 на 1 кг веса	0,25	0,3	0,4	0,5	0,5—0,75	Назначается при пневмониях, менингитах, сепсисе, гонококковых и других кокковых заболеваниях в порошках равными количествами через 4 часа (круглые сутки) в течение 6—10 дней; менее токсичен, чем сульфидин	О И Н К С)
Sucus gastricus naturalis	-1 чайная ложка	1 десертная — 1 столовая ложка		1 десертная — 1 столовая ложка		Применяется при острых и хронических расстройствах питания и пищеварения. Назначается во время еды 2—3 раза в день		
Sulglinum	Суточная доза 0,1—0,2 на 1 кг веса	0,25	0,4		0,5—0,75		См. Сульфидин. Особенно эффективен при острых и хронических бактериальных инфекциях желудочно-кишечного тракта	
Tannalbinum	0,1-0,15	0,2	0,25	0,3	0,5-1,0		Кишечное вяжущее средство. Назначается в порошках 3—4 раза в день	
Terplnum hydratum	0,025-0,05	0,05	0,1	0,15	0,25-0,3		Назначается при хроническом бронхите, гнилостном бронхите, в слизистых микстурах 3—4 раза в день	
Tlijaminum bromatum	Назначается на прием столько миллиграммов, сколько ребенку лет; но не больше 10 мг					Препарат витамина В., Применяется при гиповитаминозе В., гипотиреозах, полиневритах, радикулитах, функциональных сердечно-сосудистых расстройствах. Назначается внутри и подкожно		
Tn.iocolu.ra	0,05-0,1	0,1	0,15	0,2	0,25		0,3-0,5	Назначается как дезинфицирующее, отхаркивающее средство при хронических заболеваниях легких в порошках или в растворах 3—4 раза в день
Thyreoldinum liquidum Thyreoldinum siccura	1—2 капли 0,005—0,01	2 капли 0,012	3-4 капли 0,025	5-6 капель 0,05	8-14 Ч капель 0,1—0,15/			
Tinctura. Cliinae composita Tinctura Ferri pomati	1—2 капли 5—10 капель	2 капли капель	15		8-14 капель 40 капель			
Tinctura Opii benzoica						капель	0,1	Применяются при явлениях гипотиреоза. Назначаются в порошках или каплях 2—3 раза в день
Tinctura Stro- phanthi i						капель	0,1	Применяются при явлениях гипотиреоза. Назначаются в порошках или каплях 2—3 раза в день
Tinctura Vale- rianae Tinctura Vale- rianae aetherea	1—2 капли "1—2 капли	1 капля	По 1 ¹ / ₂ капли на 1 год жизни		7 капель 30 капель		8-15 А капель I 8-15 / капель J	Назначается как горечь перед едой 2—3 раза в день. См. препарат ы железа
		2. капли 2	3-4 капли 3—4 нашпй"	5-6 капель 5-6 капель	4 капли			
		капли						

Применяется как

отхаркивающее
средство per se
или в смеси с
другими пре-
паратами

o

Применяется
главным образом
при острой нест-
а точности сердца
3—4 раза в день

»o

W

>

Й м

Эa

O

Успокаивающи
е средства.
Назначаются 3
раза в день в
сочетании с
другими на-
стойками

йй

и o

∞

> o

e.

б!

ФАРМАК

go
вн
ь а; я га

s и
К га а
о п Я
ни и
&
S5
о чо
о.л о о
а

2 м

а <о о
ооJм
g,«^g i
Si i
SB«S я я^я
й
^ гаю В

sal
к

ЕР
го оо
fll а

да и

Эч'ацдога га
й • РВ И т К 2 а
О и Е яга
(SB о ;
д о 5oe \$• i
8н Sfev.
а и ^ ооооим д
о га я РВ йаи Е я д
гае BHEM5 я н
граул «к о 2 га
В И В Т н о 2 га
га о в я в а2 к
ани тм ИВ о 2* «
л со н в ви
fig о

Я„а”5-
ОГО”Г ЛИ в;



о .*:

о сJ

сD ^
i и
щ оо

l в

l »l i l -лл
1 г на« \$ \$
S 2 и е.«s^н а Sg^a nS^о
т т фп U3 РВ х” РЧ о
&iik.e|si
^baiга ace

В У В „О Е и р. Рі га (ц”щ — Н о
м (Д о в щ га Ф Н и и И-” «я

Р А Т К А Я	О В М Е С Т И М Ы Х	К Р А Т К А Я	е к а р с т в е н н ы х	С	Т а н и н н о м , д у б и л ь н ы м и и б е л к о в ы м и в е щ е с т в а м и , в о л я м	Что	С чем	Наименование	Л
	Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х	Т А Б Л И Ц А	Алкалоиды п их соли						
	7	2	7						
	В	Е	Н						
	Н	Ы	Х						
	С	М	Е						
	Б	Л	И						
	Ц	А							
	О								
	Н								
Е									
С									
Л									

Продолжение

Наименование лекарственных препаратов	С чем несовместимо.....	Что образуется
Сода двууглекислая	С кислотами, кислыми	Выделение угле-
Таннин	С бертолетовой солью, марганцовокалиевой солью и другими окислителями	Взрывчатые смеси
Хлоралгидрат	С щелочами, камфорой, антипирином, ментолом и др.	Разложение и разжижение
Щелочи	С кислотами и кислыми солями	Нейтрализация
Эмульсия	С жирами	Омывание
Эфирные масла	С алкалоидами	Осажки
	С кислотами, кислыми солями, кислыми сиропами и спиртовыми препаратами	Разложение
	С щелочами, бромом, хлором, азотной кислотой	Воспламенение

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ

(по Фармакопее VIII)

Лекарственные вещества	Лекарственные формы, дозы, способы и цель применения
Адреналин Аммиак Анестезин Айоморфин Бертолетова соль с квасцами Глюкоза Дигален-нео Дигинорм Дионин Диуретин Желтая кровяная соль Известковая вода j	Sol. Adrenalinum 0,1% in amp. 1 мл; под кожу 0,5—1 мл. Для сужения сосудов Нашатырный спирт Anaesthesini pulv. 0,5. Присыпка на рану для обезболивания Sol. Apomorphini hydrochlorici 0,5%; под кожу 1 мл раствора. Рвотное Kalii chlorici, Aluminis aa 5,0, Aquae destil. 200 мл. Полоскание для рта. Вяжущее и дезинфицирующее Sol. Glucosi Isotonicae (т. е. 5% раствор) под кожу или внутривенно 80—100 мл. Для нейтрализации ядов и энергетическое Внутрь по 20 капель 3 раза в день. Сердечное Внутрь по 20 капель 3 раза в день. Усиливающее работу сердца Dionini 0,01—0,03 внутрь. Успокаивающее кашель Мочегонное внутрь по 0,5—1,0 Sol. Kalii ferro-cyanati 1% для промывания желудка 600—1 000 мл; нейтрализующее яд (медь) Aquae Calcis; внутрь по 1 столовой ложке через 5—10 минут. Нейтрализующее яд. Aqua Calois 100 мл, разведенная водой до 1 л. Для промывания желудка ■

Продолжение

Лекарственные вещества	Лекарственные формы, дозы, способы и цель применения
i Каломель	Hydrargyri chlorati 0,3—0,4 с 0,3 молочного сахара внутрь во 1 порошок через 2 часа до действия. Слабительное
Камфора	Olei camphorati 10% in amp. 1 мл; под кожу 1—2 мл. Для усиления сердечной и дыхательной деятельности
Карбоген	Смесь углекислоты (5—7%) с кислородом (до 100%) для вдыхания. Окисляющее кровь и возбуждающее дыхательный центр
Кодеин	По 0,03—0,05 с 0,3 сахара; внутрь. Успокаивающее кашель
К^наин	Sol. Cocaini hydrochlorici 1%; под кожу 1—2 мл, а в глаза — по 2—3 капли. Местно-обезболивающее
Коразол	Sol. Corasoli 10% in amp. по 1 мл; под кожу 1—2 мл. Усиливающее деятельность сердца
Кофеин	Sol. Coffeini natro-benzoici 10—20% 1 мл; под кожу 1—2 мл. Возбуждает сердечную и дыхательную деятельность.
Мы незия жженая	Взвесь 30,0—50,0 жженой магнезии в стакане воды; внутрь на один прием или повторно через 1—2 часа. Взвесь 50,0—70,0 жженой магнезии в 600—800 мл воды для промывания желудка. Нейтрализует и адсорбирует яды
Морфин	Sol. Morphini hydrochlorici 1 %; под кожу 1—2 мл. Обезболивающее
Омьопон	2% раствор; под кожу 1—2 мл для обезболивания
Опий	Opii pulverati; внутрь 0,02—0,05 на прием 4 раза в день. Opii simplex; внутрь 6—12 капель на прием 3 раза в день. Оба лекарства для устранения боли в кишечнике и прекращения поноса
Папаверин	Sol. Papaverini hydrochlorici 2%; под кожу 1—2 мл для устранения кишечных колик и спазмов
Противоядие от металлов	Antidotum metallorum внутрь 50—100 мл или 200 мл, разбавив 800 мл воды. Для промывания желудка. Нейтрализует металлические яды
Противоядие от мышьяка	Antidotum arsenici внутрь чайными ложками через 5 минут повторно 8—10 раз. Для нейтрализации яда
Слизистые отвары	Infusi radiceis Althaeae или Mucilaginis Salep, или Mucilaginis Gummi arabici; внутрь 15—20 мл, разведя 200 мл воды и добавив 15,0—20,0 сахара; принимать столовыми ложками через 5—10 минут. Защищающее слизистую оболочку желудка от раздражения и замедляющее всасывание яда

■ ! При остром отравлении барбитуратами — вероналом, люминалом - 1—2 мл под кожу или внутривенно.

$\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H} - \text{C} - \text{Mn} - \text{S} - \\ | \quad | \quad | \quad | \\ \text{O} \quad \text{O} - \text{HO} \\ ||| \\ -\text{O}-\text{O}- \end{array}$

$$\begin{array}{c} \text{R}^{\circ} \\ | \\ \text{O} \end{array}$$

eg

i ig i

 $\wedge$

3-&
п

И в «Я
за „

^SS а а в В
Лй
су II S
и га о гра о, s
О Я i A
Wf κ 2SR
B Ш я м o
я с c c
о ч н
Ф (n)
Р B
н F
ии он со

АНТИБИОТИКИ

Первоначальные наблюдения об антагонизме между бактериями и мысль об использовании одного вида бактерий для уничтожения другого относятся ко второй половине прошлого века. В 70 к годах прошлого века (1868—1872) ученики С. П. Боткина А. Г. Полотебнов и В. А. Манассеин опубликовали ряд работ, в которых доказали, что культура (особенно молодая) зеленого кисте-ника, или зеленой плесени (*Penicillium glaucum*), на пастеровской жидкости полностью устраняет рост на ней бактерий и других грибов, что зеленая плесень, приложенная в виде повязок на различные язвы и раны, приводит к очищению дна язвы, уменьшению инфильтрации по краям, полностью предохраняет от вторичной инфекции. Таким образом, нельзя не отметить, что работам Флеминга, приведенным в 1929 г. к выделению пенициллина, предшествовали исследования русских ученых А. Г. Полотебнова и В. А. Манассеина. Антагонизм между микробами в 1889 г. получил название антибиоза (от греческих слов *anti* — против и *bios* — жизнь), а вырабатываемые при этом микробами вещества — антибиотиков. Первым использовал для практических целей явления антагонизма между микробами великий русский ученый И. И. Мечников. По его предложению стала с успехом применяться для предупреждения и лечения кишечных инфекций простокваша, содержащая палочки молочнокислого брожения и продукты их жизнедеятельности. Он первый блестяще доказал, что одни из микробов безразличны, а другие — вредны для организма.

В настоящее время в СССР антибиотики получают на специальных заводах. Партия и правительство придают огромное значение проблеме антибиотиков.

Из полученного до последнего времени большого числа антибиотиков самое широкое применение получил пенициллин. Используются также при многих заболеваниях грамицидин С (советский), стрептомицин, эритроин и др.

Грамицидин С (Gramicidin)

В 1942 г. лауреатами Сталинской премии Г. Ф. Гаузе и М. Г. Бражникова получен грамицидин. Это вещество, названное грамицидином С (советский грамицидин), обладает высоким бактерицидным и бактериостатическим действием в отношении стафилококков, стрептококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции и других грамположительных микробов.

От заграничного грамицидина Дюбо грамицидин С отличается высокой химиотерапевтической активностью в отношении стафилококковой инфекции, действием на грамотрицательных микробов — палочки брюшного тифа, паратифа, дизентерии, протей, кишечную палочку (этим действием грамицидин Дюбо не обладает).

Грамицидин С — светлосерый порошок, нерастворимый в воде, растворим в спирту. Применяется только местно, так как обладает гемолитическим действием. Грамицидин С выпускается в ампулах по 1 или 2 мл или во флаконах в виде 4% стерильного

ного спиртового раствора. Применяется в виде свежеприготовленных 0,04—0,08% растворов (т. е. разведением продажного раствора в 50—100 раз) на стерильной дистиллированной воде или прокипяченной питьевой воде. Водный раствор опалесцирует, нестойк и подлежит употреблению в день изготовления.

Для изготовления жирового раствора грамицидина спиртовой раствор разводят жиром (касторовое масло, рыбий жир, ланолин и т. п.) в 25—50 раз. Жировой раствор может храниться в течение долгого времени. Грамицидин С быстро и значительно уменьшает количество микробов в ране, способствует быстрому ее очищению и освобождению от омертвевших мягких тканей, ускоряет рост эпителия с периферии раны и заживление ее.

Показания к применению грамицидина (инструкция, утвержденная фармакологическим комитетом Ученого медицинского совета Наркомздрава СССР 31/VI 1943 г.): 1) гнойные раны мягких тканей, 2) остеомиелиты, 3) эмпиемы, 4) нагноения после ожогов.

Способ применения: обмывание, орошение ран, наложение влажных повязок, введение тампонов, обильно смоченных водным раствором грамицидина.

Противопоказания к применению грамицидина: 1) внутривенное введение растворов грамицидина (гемолитическое действие), 2) кровотечение из гранулирующей поверхности раны.

Rp. Sol. Gramicidini spirituosae 4% 1,0

D. t. d. N. 4 in amp.

S. Перед употреблением спиртовой раствор разводится стерильной дистиллированной водой в 1С4) или 50 раз Применяется только местно!

Пенициллин (Penicillinum)

Наиболее распространенными препаратами пенициллина являются его безводные натриевая и кальциевая соли, которые выпускаются в специальных флаконах, содержащих 100 000—1 000 000 единиц действия (ЕД). В последнее время, наряду с аморфным препаратом, выпускается кристаллический пенициллин. Активность пенициллина определяется в единицах действия. В настоящее время за единицу действия пенициллина принята активность 0,6 микрограмма кристаллического стандартного пенициллина (G).

Продажные препараты пенициллина содержат в 1 мг не меньше 1 000 ЕД. Имеются, однако, уже препараты, активность которых равна 1 600—1 800 ЕД в 1 мг.

Пенициллин — малостойкое вещество. Сухой препарат в ампулах при температуре ниже 10° сохраняется 6 месяцев; растворы очень нестойки. Кристаллический пенициллин сохраняет свою активность до 2 лет. Растворы пенициллина для инъекций готовят на стерильном физиологическом растворе поваренной соли. Ис следует при стерилизации шприца или иглы добавлять к воде щелочи (бикарбо-

нат натрия) или пользоваться спиртом, так как пенициллин быстро при этом разрушается. Ни в коем случае нельзя раствор пенициллина нагревать и тем более кипятить, так как быстрота его разложения нарастает вместе с повышением температуры. Ценная особенность пенициллина состоит в том, что он, действуя химиотерапевтически против многих микробов, в то же время не обладает органо-тропным действием, т. е. не повреждает органы человека. Пенициллин разрушается тяжелыми металлами (медью, ртутью, свинцом), спиртами (метилловым и этиловым), окисляющими веществами (перекисью водорода, марганцовокислым калием); поэтому указанные вещества не следует применять для обработки ран перед применением пенициллина или во время курса лечения им. Чаще пенициллин применяют парэнтерально: внутривенно, внутримышечно, и в виде аэрозолей местно. В желудочно-кишечном тракте при приеме внутрь или введении в двенадцатиперстную кишку или в прямую кишку пенициллин быстро разрушается соляной кислотой желудочного сока, щелочным содержимым и бактериями кишечника, и после всасывания в кровь не создаются концентрации, необходимые для лечебного действия. Для создания необходимой лечебной концентрации пенициллина в крови при приеме внутрь требуется в 5 раз больше пенициллина, чем при введении его в вену. В настоящее время выпускается пенициллин-натрий в таблетках; каждая таблетка содержит 20 000 или 50000 ЕД. Назначают внутрь за %—1 час до еды и через 2—3 часа после еды, запивая таблетки 2% раствором соды.

Для местного действия пенициллин применяется в виде: 1) мази (сухой пенициллин на спермацетовой или другой основе из расчета 500—1 000 ЕД в 1,0 мази); 2) присыпки часто в сочетании с сульфамидными препаратами из расчета 10 000 ЕД на 1 г сульфамидного препарата и на физиологическом растворе в виде капель, примочек, влажных повязок (250—500 ЕД в 1 мл раствора). Дозировка пенициллина меняется в зависимости от характера заболевания и реактивности организма.

Для пролонгирования действия пенициллина в последнее время применяют два способа: первый, предложенный И. Г. Руфано-вым, введение пенициллина в 1% растворе пиридоксина и в 0,5—1% растворе новокаина, предложенный А. А. Вишневым.

Экспериментально установлено (З. В. Ермольева), что при растворении пенициллина в 0,5—1—2% новокаина пенициллин полностью сохраняет свою активность на протяжении 24 часов после соединения компонентов.

При подкожном и внутримышечном введении пенициллина в 0,5—1% растворе новокаина антибиотик обнаруживается в крови в течение 8—12 часов, а при внутримышечном в течение 6 часов.

Таким образом, этот способ позволяет совершенно без ущерба для терапевтического эффекта пенициллинотерапии снизить число уколов до 2—3 раз в сутки.

Наряду с применением одного пенициллина в 0,5—1% растворе новокаина или в 1% растворе пиридоксина, в последнее время принято для prolongации действия пенициллина введение пенициллина с экмолином, в особенности с комбинацией новокаина.

Терапевтический эффект внутримышечной инъекции пенициллина с экмолином и новокаином 2 раза в сутки не ниже эффекта при введении одного пенициллина каждые 3 часа.

Техника применения следующая: во флакон с пенициллином на каждые 100 000 единиц прибавляют стерильно (шприцем через резиновую пробку) 1 мл 1% раствора новокаина, а затем 1 мл экмолина; 2 мл опалесцирующего раствора вводят внутримышечно. При стоянии этот комбинированный препарат становится более прозрачным; активность сохраняется даже при комнатной температуре в течение суток. Этот комбинированный препарат вводят не больше 2—3 раз в сутки. В более тяжелых случаях заболеваний одноразовая доза комбинированного препарата должна быть увеличена до 200 000 единиц. Детям пенициллин с экмолином и новокаином вводят внутримышечно 3 раза в сутки по 50 000—75 000 ед. По данным З. В. Ермольевой, экмолин усиливает и пролонгирует действие пенициллина не только при внутримышечном введении, но и при приеме внутрь и при аэрозольной ингаляции.

Таблетки пенициллина с экмолином для приема внутрь обеспечивают терапевтическую концентрацию пенициллина в крови в течение 6 часов, а без экмолина — в течение 3—4 часов.

При приеме внутрь детьми (до 2 лет) 75 000 единиц кристаллического пенициллина с экмолином терапевтическая концентрация пенициллина в крови сохраняется в течение 8 часов, без экмолина — 3—4 часа. Та же доза аморфного пенициллина с экмолином обеспечивает терапевтическую концентрацию пенициллина в крови у маленьких детей в течение 4 часов; без экмолина — на протяжении 1/2 часов.

Препарат экмолин разрешен Фармакологическим комитетом к выпуску и рекомендован Ученым медицинским советом Министерства здравоохранения СССР для профилактики и лечения гриппа и для удлинения срока действия пенициллина в организме.

Применение аэрозолей пенициллина и стрептомицина. В последнее время получен хороший эффект при ингаляционном методе введения пенициллина и стрептомицина в виде аэрозолей. Этот метод технически прост и доступен для всякой больницы и в амбулаторных условиях.

Метод может использоваться при лечении различных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, в отдельных случаях применение аэрозолей можно рассматривать как метод общей пенициллино- и стрептомицинолечения. Некоторое распыление ингаляции аэрозолей легко переносится больными как детьми, так и взрослыми в течение длительного времени от 30 до 60 минут.

Длительное вдыхание аэрозолей пенициллина и стрептомицина создает терапевтическую концентрацию антибиотиков в крови на срок 8—12 часов у детей и 19—24 часа у взрослых.

Методика применения очень проста.

Дозировка пенициллина. В дозировке пенициллина трудно придерживаться какой-либо постоянной схемы. Она устанавливается в зависимости от вида возбудителя, тяжести инфекции, степени интоксикации, иммунологического состояния организма и т. д.

Эффективной средней дозой пенициллина в случаях стрептококковой и других инфекций, столь же чувствительных к пенициллину, необходимо считать 90 000—150 000 единиц в сутки. Стафилококковая инфекция требует в среднем 200 000—300 000 единиц в сутки.

При применении пенициллина следует подчеркнуть, что комбинированное лечение — пенициллин, сульфаниламиды и вакцины — в своем синергическом действии хорошо дополняют друг друга. Поэтому для получения лучшего эффекта необходимо комплексное лечение всеми имеющимися методами в распоряжении врача или фельдшера.

Побочное действие и осложнения при лечении пенициллином.

При применении пенициллина встречаются осложнения, о которых следует помнить при пенициллинотерапии: боль на месте инъекции, местные воспалительные процессы, ознобы, нередко с повышением температуры (особенно часто после внутривенных инъекций), головные боли, побледнение или покраснение кожи лица, общая разбитость, неприятный вкус во рту, чувство стеснения в груди, различные экзантемы (по типу крапивницы и т. д.), дерматиты, картина ангионевротического отека, кореподобная сыпь, узловатая эритема, зуд и боли в области яичек, эпидидимит, судороги, острое синкопе, эозинофилия крови, невриты, боли в суставах, мышечные судороги.

Но осложнения бывают чрезвычайно редко, в среднем до 1% случаев.

Принципы применения пенициллина в хирургической практике. Надо помнить основное, что эффект лечения пенициллином тем лучше, чем раньше начато лечение. В ранних стадиях этот эффект находится в зависимости от большой чувствительности бактерий, состояния микроорганизма, меньших анатомических изменений в очаге поражения, препятствующих проникновению пенициллина, обратимости анатомических изменений в очагах поражения и отсутствия добавочной (смешанной) инфекции.

По Шлапоберскому, наиболее целесообразна следующая схема различных доз пенициллина для парентерального введения: 1) малые дозы — до 50 000 единиц в сутки (практически мало применяются), 2) средние дозы — 80 000 до 250 000 единиц и 3) большие дозы — от 250 000 до 500 000 единиц в сутки.

Шлапоберский подчеркивает, что к применению малых доз пенициллина следует подходить очень осторожно. В настоящее время все более и более признается, что при недостаточных (малых) концентрациях пенициллина бактерии адаптируются к препарату и становятся резистентными. Это заставляет Шлапо-берского считать, что опасны не передозировки, а недостаточные дозы пенициллина.

При заболеваниях в брюшной полости в связи с малым проникновением в полость брюшины пенициллина следует применять большие дозы (300 000—500 000 единиц и больше в сутки). При заболеваниях мочевых путей, так как пенициллин главным образом выделяется почками, дозировка может быть невысокая — до 100 000 единиц в сутки.

При применении пенициллина надо не забывать, что пенициллинотерапия является лишь частью всего комплекса лечения больного и что вместе с применением пенициллина следует обратить внимание на улучшение и повышение сопротивляемости организма, на усиление его иммунобиологических свойств путем применения сывороток, переливания крови, физиотерапии, рентгенотерапии и т. д.

Показания применения пенициллина в хирургической практике (по Шлапоберскому)

А. Группа заболеваний, при которых имеются абсолютные показания к применению пенициллина

1. Сепсис стрептококковый, стафилококковый, диплококковый и другие виды сепсиса, вызываемые грамположительными кокками. Сепсис гококковый.
2. Анаэробная инфекция.
3. Перитониты, вызываемые пенициллиночувствительной флорой, в состав которой входят пенициллиночувствительные микробы.
4. Острый остеомиелит, вызываемый пенициллиночувствительной флорой, особенно стрептококками или стафилококками, протекающий с общими тяжелыми токсическими явлениями.
5. Инфекционные тромбозы пазух черепа.
6. Инфекционные артриты со значительными токсическими явлениями, особенно при склонности к генерализации процесса.
7. Тяжело протекающие карбункулы со значительными токсическими явлениями (особенно при локализации на лице).
8. Гнойные менингиты, энцефалиты, абсцессы мозга.
9. Эмпиемы плевры со значительными токсическими явлениями.
10. Абсцессы и гангрена легких (особенно в ранних стадиях).
11. Гнойные перикардиты.
12. При первичной обработке обширных разможенных ран, особенно в сочетании с переломом, кости.

Применение пенициллина в более ранних фазах заболевания дает лучший эффект.

Б. Группа заболеваний, при которых имеются относительные показания к применению пенициллина

1. Острые и хронические остеомиелиты, вызываемые пенициллиночувствительной флорой, без значительных токсических явлений.
2. Аппендикулярный перитонит (после аппендэктомии).
3. Карбункулы без значительных токсических явлений, общий фурункулез.
4. Абсцессы и флегмоны любой локализации, вызываемые пенициллиночувствительной флорой, при условии обязательной эвакуации гноя.
5. Инфицированные раны.
6. Инфицированные ожоги второй, третьей и четвертой степени.
7. Эмпиемы плевры, вызываемые пенициллиночувствительной флорой, протекающие без значительных токсических явлений.

8. Тромбофлебиты, особенно в острой стадии.
9. Актиномикоз любой локализации.
- 10; Сибирская язва.
11. Рожа.
12. Нома.
13. При первичной обработке ран.
14. Для профилактики инфекции — во время операции, а также в предоперационном и послеоперационном периоде.

Стрептомицин (Streptomycinum)

В открытии стрептомицина в период 1935—1940 гг. большое значение имели советские исследователи (Ю. А. Борадулина, М. А. Нахимовская, Н. А. Красильников, А. И. Короняко, А. Е. Криес), которыми был впервые серьезно изучен антагонизм актиномицетов и бактерий. Именно эти исследования дали толчок к изучению антибактериальных веществ, вырабатываемых актиномицетами.

Н. А. Красильников в 1939 г. высказал мысль о возможности использования бактерицидных свойств актиномицетов в лечении некоторых кожных заболеваний, вызываемых стафилококками. Сейчас в Советском Союзе освоено производство стрептомицина.

Стрептомицин получается из определенных штаммов актиномицетов вида *Actinomyces griseus*. Стрептомицин растворим в воде, но нерастворим в спирту. От других антибиотиков он отличается особой стойкостью. К недостаткам стрептомицина следует отнести его ядовитость. Стрептомицин действует против ряда инфекций, возбудители которых резистентны к пенициллину. Он активен в отношении многих грамотрицательных и некоторых грамположительных бактерий, особенно кислотоустойчивых; фунгицидными свойствами он не обладает. По влиянию на грамотрицательные бактерии стрептомицин значительно превосходит пенициллин.

Он приносит большую пользу при туляремии, гриппе и его осложнениях: менингите, эндокардите, ларинго-трахеите, при заболеваниях мочевых путей, хронических легочных инфекциях, эмпиемах, печеночных абсцессах и холангитах, если эти заболевания вызваны грамотрицательными микробами.

В Советском Союзе получены благоприятные результаты лечения туберкулезного менингита эндолумбальным введением стрептомицина. При легочном туберкулезе требуется длительное лечение с применением больших доз стрептомицина.

Собирание клинических материалов продолжается. Имеются указания на хорошие результаты применения стрептомицина при туберкулезе гортани, глотки и слизистой рта.

Рекомендуется местное применение его при туберкулезных эмпиемах.

Стрептомицин применяют обычно внутримышечно, подкожно, реже перорально, а также в виде ингаляций распыленного препарата.

m

Инъекции производят в ягодичные мышцы, мышцы бедра, двуглавую мышцу, меняя при каждой инъекции место введения.

Максимально переносимая суточная доза 3,0—4,0 (среднесуточная 1,0—2,0) (см. таблицу на стр. 740).

Указанные дозы являются ориентировочными. Они могут быть соответственно изменены в зависимости от состояния больного. Однако необходимо учесть, что всегда целесообразно прибегать сразу к применению максимальных доз, так как к малым дозам наступает быстрое привыкание возбудителей инфекции. Токсичность стрептомицина ясно выражена и сопровождается побочными явлениями: тошнотой, головной болью, общим недомоганием, тахикардией, появлением крапивницы, дерматита, рвоты, озноба, лихорадки и головокружением. При этих явлениях введение стрептомицина надо прекратить.

Раствор готовится на дистиллированной воде или на физиологическом растворе хлористого натрия.

Ввиду болезненности при впрыскивании добавляется 1 мл 1% раствора новокаина.

Местно применяются 2—10% растворы стрептомицина. Срок действия сухого стрептомицина до 18 месяцев; хранить его необходимо в холодном месте.

В настоящее время изучается возможность комбинированного применения стрептомицина с парааминосалициловой кислотой (ПАСК) и ее натриевой солью. Оказалось, что эффективность стрептомицина увеличивается при одновременном применении ПАСК, т. е. развитие резистентности микроорганизмов к стрептомицину может быть задержано, а побочное действие его уменьшено. В отсутствие ПАСК резистентность туберкулезных бактерий к стрептомицину, по некоторым данным, отмечается у 8% больных, у которых продолжают обнаруживаться положительные культуры по истечении 4 месяцев. При лечении ПАСК случаи эти снижаются до 3%.

Однако и ПАСК присущ ряд недостатков: туберкулезные бактерии становятся резистентными и к пей; в процессе лечения могут возникать некоторые кожные проявления, иногда частый прием сопровождается симптомами гастроэнтерита, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и поносами, что имеет место и в том случае, когда это вещество дается в виде натриевой соли.

* Эритроин (Erythrinum)

Эритроин — антибиотическое вещество, выделенное советскими учеными (Л. Я. Зильбер и Л. М. Якобсон, 1946) из красных кровяных шариков (эритроцитов) человека и животных. Обладает выраженным бактериостатическим и бактерицидным действием в отношении дифтерийной палочки, стафилококка и др. Представляет собой черный порошок, растворимый в щелочах и спирту. Применяется для профилактики и лечения дифтерии. Эритроин растворяют в количестве 0,25 в 100 мл 3,8% раствора лимоннокислого натрия при нагревании. Приготовленный раствор используют разными спо-

Таблица дозировки стрептомицина при некоторых видах заболеваний

Вид заболевания	Суточная доза	Способ введения	Промежутки между последующими введениями	Продолжительность лечения
Туляремия	0,5-1,0-2,0	Внутримышечно	3—4 часа	5—7 дней
Менингит у взрослых	0,5-4,0	Внутримышечно	3—4 часа	5—7 дней
Менингит у детей	45 мг на 1 кг веса	Внутримышечно	3 часа	5—7 дней
Бактериемия	2,0-4,0	Внутримышечно	3—4 часа	5—10 дней
Инфекции мочевых путей	1,0-3,0	Внутримышечно	3—4 часа	5 дней
Бациллярная дизентерия	1,0-4,0	Внутримышечно И пер 08	4 часа	4—10 дней
Перитонит	2,0-4,0	Внутримышечно	3—4 часа	7—10 дней
Пневмония	2,0—3,0	Внутримышечно	3—4 часа	5—10 дней
Хронические легочные инфекции	1,0-3,0 или 0,5	Внутримышечно Ингаляции	3—4 часа Множественно	7 дней 7 дней
Туберкулез	2,0-3,0	Внутримышечно	—	3—4 месяца
Эндокардит	2,0-4,0	Внутримышечно	3—4 часа	3—4 недели
Перед операционными вмешательствами на кишечнике	3,0-4,0	Пер 08	6 часов	

собами для лечения дифтерии: в виде полоскания, пульверизации, а также в виде смачивания в этом растворе тампонов. Эритроин применяют в теплом виде, для чего пробирку с препаратом ставят перед употреблением в горячую воду.

Экмолин (Ecmolinum)

Предложен проф. З. В. Ермольевой с сотрудниками Л. К. Валидинской, А. Е. Азлецкой, А. М. Рыкаловой. Препарат — антибиотик животного происхождения. Легкий порошок желтоватого цвета. Растворим в воде, нерастворим в спирту, эфире.

Применяется экмолин при вирусном гриппе. Препарат вводится в нос в виде 0,5% раствора по 4—5 капель 2—3 раза в день до полного выздоровления. Детям — по 2 капли. В более тяжелых случаях вводится внутримышечно по 1 мл 0,5% раствора 2 раза в день в течение лихорадочного периода. Одновременно препарат вводится и в нос по указанной выше дозировке. Эффективность эк-молина более выражена в тяжелых случаях вирусного гриппа. Препарат не вызывает местной реакции и не дает побочных явлений.

Выпускается во флаконах, герметически закрытых резиновой пробкой, по 25, 50, 75 и 100 мг, а также по 10 мл готового раствора для впуска в нос.

Хранить при комнатной температуре. Срок годности — 2 года со дня выпуска.

Вр. Sol. Ecmolini 0,5% 10,0

DS. По 4—5 капель в нос 2—3 раза в день ?

Альбомин (Albomyeinum)

Альбомин представляет собой оригинальный отечественный антибиотик, впервые полученный в лаборатории антибиотиков в Академии медицинских наук СССР проф. Г. Ф. Гаузе и старшими научными сотрудниками М. Г. Бражникова, В. А. Шориным и С. Д. Юдицевым. Альбомин может быть в виде порошка желтого или пластинок бурого цвета. Хорошо растворим в дистиллированной воде.

Альбомин не токсичен при введении животным больших доз препарата. Препарат подавляет рост как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

Для клинического применения альбомин должен содержать не менее 8 000 единиц в 1 мг. Препарат в сухом виде сохраняет активность при комнатной температуре не менее года с момента его изготовления.

В Институте педиатрии Академии медицинских наук СССР проф. А. И. Доброхотовой разработана методика применения альбомина при лечении пневмоний и септических осложнений дизентерии у детей первого года жизни.

Способ употребления альбомина. Альбомин стерильно расфасован во флаконах, содержащих по 1 000 000 единиц. Резиновую пробку прокалывают стерильной иглой и

во флакон шприцем вводят стерильную, дважды дистиллированную воду из расчета 5 мл во флакон, содержащий 1 000 000 единиц.

Содержимое флакона несколько раз встряхивают для более быстрого растворения антибиотика. Таким образом, полученный раствор содержит 200 000 единиц в 1 мл. Водный раствор сохраняется на холоде и пригоден к употреблению в течение 24 часов с момента его изготовления.

Суточные дозы препарата колеблются от 100 000 до 200 000 единиц на 1 кг веса ребенка в зависимости от тяжести заболевания. Суточная доза делится на три равные дозы с ночным интервалом между инъекциями в 12 часов и дневным — в 6 часов (например, в 9, 15 и 21 час). Следовательно, каждый раз ребенок получает инъекцию от 30 000 до 70 000 единиц на 1 кг веса или от 0,15 до 0,35 мл раствора альбомуцина на 1 кг веса (например, ребенок весом в 5 кг при суточной дозе 150 000 единиц на 1 кг получит за сутки 750 000 единиц; в 9 часов — 250 000 единиц, или 1,25 мл раствора, в 15 часов — также 250 000 единиц, или 1,25 мл раствора, и в 21 час — еще 250 000 единиц, или 1,25 мл раствора).

Раствор альбомуцина следует вводить под кожу. Введение раствора безболезненно и образования инфильтратов не вызывает.

Иногда в окрестности места введения раствора появляется гиперемия или мелкая пятнистая сыпь преходящего характера, исчезающая в течение первых суток. Обычно курс лечения продолжается 7—12 дней, но в случаях необходимости применения препарата может быть более длительным — 17—20 дней. Кумулятивной токсичностью препарат не обладает.

Альбомуцин может применяться одновременно с препаратами сульфаниламидного ряда, пенициллином, стрептомицином, синтомицином и со всеми вспомогательными средствами неспецифической терапии, как переливание крови, плазмы, введение глюкозы и пр.

Клинические показания к применению альбомуцина: 1. При пневмонии у детей первого года жизни различной этиологии.

2. При пневмонии у детей первого года жизни, не поддающейся лечению пенициллином.

3. Осложнения при дизентерии у детей первого года жизни: а) пневмонии, б) отиты, в) отиты-анtritы.

4. При различных септических состояниях детей первого года жизни, не поддающихся лечению пенициллином, как, например, пиодермиты, абсцессы различных локализаций, сепсисы и т. д.

Клинические противопоказания к применению альбомуцина. Имеются указания, что стрептококковые инфекции хуже поддаются лечению альбомуцином, чем пневмококковые, стафилококковые и грамотрицательные инфекции.

Лизоцим (Lysozim)

Лизоцим — это бактерицидное вещество, содержащееся в слезах, мокроте, слизи носа, слюне, сыворотке крови, плазме, фибрине и других различных органах животных, а также в растениях (хрен, редька, капуста и др.). Лизоцим выпускается в ампулах 10—15 мл.

❧

Терапевтическое применение лизоцима установлено было по инициативе З. В. Ермольевой еще в 1931 г.

Лизоцим восстанавливает жизнедеятельность тканей, способствует быстрому возвращению их в нормальное состояние. Лизоцим особенно применяется при заболеваниях носа и горла.

Лизоцим применяется следующим образом: путем вкапывания в нос 5—7 капель 2 раза в день или вводятся марлевые или, лучше, ватные полоски, хорошо пропитанные лизоцимом, и закладываются коленчатым пинцетом в нижние и средние носовые ходы. Марлевые полоски или ватные тампоны остаются в носовой полости на 10—15 минут. Хорошо при этом носовую полость с находящимися в ней лизоцимовыми тампонами прогреть электролампой с рефлектором или просто теплой грелкой в течение 4—7 минут.

Лечение лизоцимом применяется при повторных ринитах, хронических воспалениях придаточных полостей носа, атрофических ринитах, при дифтерийном бациллоносительстве, подтвержденном бактериологическим анализом слизи носовой полости; при хронических ринитах и синуситах у больных, перенесших оперативное лечение, но не излечившихся; при гайморитах и атрофических фарингитах (систематические смазывания и втирания); при хронических тонзиллитах (смазывания, промывания крипт гортанным шприцем или канюлей); при ларинготрахеитах, бронхитах (пульверизация, ингаляция); воспалениях наружного и среднего уха, при незаживающих свищах после операции сосцевидного отростка.

Лизоцим абсолютно безвреден и хорошо переносится больными всех возрастов.

Левомецетин (хлоромецетин) (Levomycetinum, Chloromycetinum)

Антибиотик левомецетин был открыт в 1947 г. В 1949 г. левомецетин был синтезирован в СССР (Институт биологической и медицинской химии АМН СССР). Левомецетин — почти бесцветное кристаллическое вещество горького вкуса, устойчивое как в сухом виде, так и в растворимом, чем он и отличается от пенициллина.

Левомецетин можно принимать в виде порошков, так как он не разрушается в желудке и кишечнике.

В настоящее время левомецетин применяется при лечении следующих заболеваний: брюшной тиф и паратифы, дизентерия, сыпной тиф, марсельская лихорадка, бруцеллез, туляремия, пневмония, трахеит и ряд других заболеваний.

При лечении левомецетином брюшного тифа и паратифов А и В удается добиться выздоровления почти 100% заболевших. В среднем на курс лечения необходимо 25—30 г левомецетина, в тяжелых случаях необходимо применять 50—60 г. Клинически доказано благоприятное действие на больных сыпным тифом. После 2—3 дней лечения левомецетином больных сыпным тифом температура и пульс возвращаются к норме, а через 3—6 дней исчезают все клинические явления. В среднем на курс расходуется 5—6 г антибиотика. В редких случаях приходится увеличивать дозу до 10—12 г.

В острых случаях бруцеллеза при применении левомецетина на 2-е сутки наступает общее улучшение состояния больного, на 3-й

сутки обычно температура снижается до нормы, а через 7—8 дней больной выздоравливает. На курс лечения необходимо 15—20 г левомицетина.

Левомицетин дается в таблетках или желатиновых капсулах по 0,5—1,0 от 4 до 8 раз взрослым в день в зависимости от заболевания. Детям в зависимости от возраста, согласно общепринятому уменьшению дозировки по Государственной фармакопее.

Фитонциды

(антисептики растительного происхождения)

Фитонцидные свойства обнаружены Б. П. Токиным и его сотрудниками в ряде (свыше 200) высших растений: луках, чесноках, крохлебке, горчице, редьке, хрене, апельсиновом дереве, диком пионе, березе, черной смородине и др. Наиболее интересны разные луки и чесноки. Выяснено, что способность летучих фракций и тканевых соков этих растений убивать протозоа универсальна: в первые же минуты погибают многие как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. Изучено влияние фитонцидов на дифтерийную палочку, холерного вибриона, тифо-дизентерийную группу микробов, на стафилококков, стрептококков, на палочку штамма БЦЖ, *Perfringens* и на другие бактерии.

Фитонциды чеснока оказались гораздо более бактерицидными, чем фитонциды лука. Так, опыты по воздействию летучими фракциями фитонцидов на дизентерийных микробов, посеянных на агаре, подтвердили исключительную бактерицидную силу чеснока: нередко достаточно пятиминутной экспозиции воздействия соком чеснока, чтобы обнаружить полную стерильность или рост лишь единичных колоний.

Вопросы химии и биохимии фитонцидов еще недостаточно изучены. Торопцевым и Камневым разработана методика получения бактерицидного вещества из чеснока, названного авторами дефензона-том. Это вещество небелковой природы, близко стоит к гликозидам.

Другими исследователями выяснено, что в зависимости от количества фитонцидов лука активность пероксидазы крови человека снижается от 6 до 73%; небольшие количества фитонцидов чеснока несколько увеличивают активность пероксидазы. Авторы приходят к выводу о возможности объяснения биологической активности фитонцидов действием их на ферментные системы.

Высказанные Б. П. Токиным взгляды относительно существования проантибиотиков весьма важны в связи с последними работами по аллицину и аллину — антибиотику и проантибиотику.

Аллицин был получен в 1945 г. из чеснока в чистом виде посредством метода, аналогичного методу выделения пенициллина. Он убивает как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. В разведении 1 : 85 000 и 1 : 125 000 задерживает рост стафилококков, стрептококков, дизентерийных палочек, холерного вибриона, тифозной палочки и др.; в тех же условиях пенициллин в разведении 1 : 5 000 не действует на *B. typhosus*. Действие аллицина не парализуется парааминобензойной кислотой: он очень нестойк и токсичен.

Установлено, что препараты чеснока, в которых энзим разрушен, не обладают характерным запахом или вкусом.

В настоящее время можно считать научно обоснованным применение фитонцидов при заболеваниях кишечника, вызываемых бактериями и патогенными простейшими, при трихомонадном кольпите, при лечении инфицированных ран и других заболеваний. При трихомонадном кольпите успешно применяется «луковый тампон»: луковицу, очищенную от сухих листьев, быстро протирают через овощную терку на кусочек марли (10 ХЮ см) и в виде марлевого тампопа вводят во влагалище на 8—10 часов. Курс лечения — 5—6 (8—10) дней.

А л л и ч е н Ч вытяжка из лука: светложелтая жидкость, получаемая при настаивании измельченного лука на 90° спирту. Применяется при атонии кишечника, колитах с наклонностью к запорам, артериосклерозах. Назначают по 20—30 капель 3 раза в день на воде или молоке за 15 минут до еды. Курс лечения — 3—4 недели. Побочных явлений не отмечается даже при длительном лечении. Выпускается во флаконах по 50 мл.

ЛЕЧЕБНЫЕ СЫВОРОТКИ

Лечебные сыворотки получают из крови животных (чаще всего лошадей, подвергавшихся продолжительной иммунизации различными микробами и их продуктами — токсинами и анатоксинами).

В зависимости от вида иммунизации сыворотки разделяют на антитоксические и антибактериальные.

Для иммунизации выбирают вполне здоровых лошадей. После кровопускания сыворотку, отделенную от сгустка, выдерживают 4 месяца до употребления.

В тех случаях, когда сыворотку подвергают нагреванию при 56° в течение часа, она может быть употреблена через 2 месяца с момента кровопускания.

Сыворотки представляют собой желтоватую или зеленоватую, иногда слегка опалесцирующую жидкость без запаха или с запахом консерванта. Сыворотки консервируют хлороформом (не более 0,5%), хинозолом (не более 0,05%), фенолом (не более 0,5%), трикрезолом (не более 0,4%).

Сыворотки, консервированные фенолом или трикрезолом, для внутривенных и спинномозговых инъекций не употребляют.

Сыворотки прозрачны или слегка опалесцируют в момент приготовления; в дальнейшем, при хранении, выпадает легкий осадок. Этот осадок не служит признаком порчи; жидкость над осадком остается прозрачной и сохраняет свою эффективность. Наличие неразвивающегося при встряхивании осадка, образование неразвивающихся хлопьев, нитей, общее помутнение, изменение цвета, наличие дурного запаха служат признаком порчи сыворотки.

Сыворотки должны быть стерильны и безвредны в опытах на животных и не должны содержать бактериальных токсинов или других бактериальных продуктов.

Лечебные сыворотки можно употреблять также в очищенном и концентрированном виде. Считают доказанным, что антитоксины

сыворотки связаны с псевдоглобулиновой, а антитела антибактериальных сывороток главным образом с эйглобулиновой фракцией сыворотки. Метод очистки и концентрации сывороток заключается в выделении указанных фракций (благодаря чему осуществляется очистка от ненужных белковых фракций) и в последующем их растворении в меньшем объеме; благодаря чему увеличивается концентрация. Если при выделении указанных фракций сыворотки употребляют высаливание с последующим диализом, то такие сыворотки называют диализованными.

Преимущество этих сывороток — большое количество активных единиц в 1 мл, в силу чего в организм вводят меньше чужеродных и балластных белков, обуславливающих так называемые сывороточные явления. На этикетке ампул, содержащих указанные сыворотки, помимо данных, обязательных для обыкновенной сыворотки, должно иметься указание на то, что сыворотка диализована и освобождена от балластных веществ.

Требования, предъявляемые к очищенным и концентрированным сывороткам и к иативным сывороткам, одинаковы.

Все лечебные сыворотки подлежат обязательному государственному контролю, согласно специальной инструкции Министерства здравоохранения СССР.

Активность сывороток определяется содержанием в них антитоксических, или протективных, единиц.

Определение активности сывороток (титрование) производят по стандартам, рассылаемым по производственным институтам Центральным государственным научно-контрольным институтом. Минимальная допустимая активность сыворотки (минимальный титр) определяется постановлением Министерства здравоохранения СССР.

Сыворотку разливают асептически в стерилизованные ампулы, которые запаиваются.

Каждая ампула должна быть снабжена этикеткой, содержащей следующие сведения: 1) наименование института, изготовившего сыворотку; 2) дату изготовления; 3) номер серии; 4) наименование препарата; 5) количество активных единиц; 6) номер и дату государственного контроля; 7) срок годности препарата; 8) количество содержимого в каждой ампуле.

Хранение. Сыворотки сохраняют в защищенном от света месте при температуре от +2° до +10°. Сыворотки, подвергавшиеся однократному промерзанию и не изменившие своих внешних свойств, годны к употреблению. Срок годности 2 года.

Противоботулиническая сыворотка

Сыворотка крови лошадей, иммунизированных в течение продолжительного времени анатоксином или токсином культуры *B. botulinus*.

Противоботулинические сыворотки готовят или моновалентные (см. статью «Вакцины») — против типа А и В, или поливалентные — против обоих типов.

Титр сыворотки, т. е. количество антитоксических единиц (АЕ), не должен быть ниже 1000 АЕ в 1 мл.

Сыворотку употребляют с лечебной, иногда с профилактической целью.

Количество антитоксических единиц, вводимое с лечебной целью, достигает 50 000—100 000 АЕ и больше. Сыворотку вводят внутривенно или внутримышечно каждый день до исчезновения клинических явлений.

С профилактической целью вводят внутримышечно 10000—15000 АЕ.

Противодифтерийная сыворотка

Антитоксическая сыворотка крови лошадей, иммунизированных в течение продолжительного времени дифтерийным анатоксином.

Титр сыворотки, т. е. количество антитоксических единиц, определяемое при помощи стандартного дифтерийного токсина, не должен быть ниже 600 АЕ в 1 мл.

Сыворотку назначают с лечебной и профилактической целью.

Количество антитоксических единиц, вводимое с лечебной целью, колеблется от 5 000 до 30 000 АЕ, смотря по характеру заболевания, времени, прошедшему от начала заболевания, и способу введения сыворотки; количество антитоксических единиц, вводимое с профилактической целью, равно 1 000 АЕ.

Препарат вводят подкожно или внутримышечно.

Противодизентерийная сыворотка

Противодизентерийная сыворотка крови лошадей, иммунизированных в течение продолжительного времени дизентерийным (Шига) токсином или анатоксином. Действующим веществом сыворотки является дизентерийный анитоксин (Шига).

Титр сыворотки, т. е. количество антитоксических единиц, определяемое при помощи стандартного сухого дизентерийного (Шига) токсина, не должен быть ниже 600 АЕ в 1 мл.

Сыворотку назначают с лечебной целью.

Количество антитоксических единиц, вводимое с лечебной целью, колеблется от 15 000 до 30 000 АЕ, смотря по характеру заболевания, времени, прошедшему от начала заболевания, и способу введения сыворотки.

Препарат вводят подкожно или внутримышечно.

Сыворотки против газовой гангрены

Сыворотки крови лошадей, иммунизированных в течение продолжительного времени анатоксинами, токсинами и анакультурами возбудителей газовой гангрены — *B. perfringens*, *B. oedematis*, *B. vibrio*, *B. histolyticus*.

Сыворотки готовят против каждого из четырех видов возбудителей отдельно и перед употреблением смешивают в определенных соотношениях.

Титр сывороток, т. е. количество антитоксических единиц в 1 мл, для сывороток antiperfringens, antivibriosepticus и antihistolyticus не должен быть ниже 100 АЕ, а для antioedematicus — 1 000 АЕ.

Сыворотки употребляют с профилактической и лечебной целью. С профилактической целью сыворотки вводят раненым (при наличии ран, загрязненных землей) подкожно в следующих соотношениях: antiperfringens — 1 £00 АЕ, antioedematicus — 2 500 АЕ, antivibriosepticus — £00 АЕ, antihistolyticus — £00 АЕ. С лечебной целью в большинстве случаев также употребляют смесь указанных сывороток. Сыворотки вводят внутримышечно или внутривенно обычно в смеси со стерильным, нагретым до температуры тела физиологическим раствором из расчета на 100 мл сыворотки 100—400 мл физиологического раствора.

Противопневмококковая сыворотка

Сыворотка крови лошадей, иммунизированных в течение продолжительного времени культурой пневмококка (Pneumococcus I и II pneumoniae), а именно его разновидностью, известной как тип I. В ней содержатся превентивные антитела.

Титр сыворотки, т. е. количество превентивных, или иммунных, единиц (ИЕ), определяемых по методу Фельтона, не должен быть ниже 100 ИЕ в 1 мл.

Сыворотку назначают с лечебной целью. Количество иммунных единиц, вводимое с лечебной целью, колеблется от 20 000 до 20 000 ИЕ, смотря по характеру заболевания, времени, прошедшему, от начала заболевания, и способу введения сыворотки.

Препарат вводят внутримышечно или интравенозно.

Противоскарлатинозная антитоксическая сыворотка

Сыворотка крови лошадей, иммунизированных в течение продолжительного времени токсином гемолитического скарлатинозного стрептококка. В ней содержится скарлатинозно-стрептококковый антиоксин.

Титр сыворотки, т. е. количество антитоксических единиц, определяемых при помощи стандартного скарлатинозно-стрептококкового токсина, не должен быть ниже 250 АЕ в 1 мл.

Сыворотку назначают с лечебной целью. Количество антиоксических единиц, вводимое с лечебной целью, колеблется от 6 000 до 15 000 АЕ, смотря по характеру заболевания, времени, прошедшему от начала заболевания, и способу введения сыворотки.

Препарат вводят подкожно, внутримышечно или интравенозно.

Противостолбнячная сыворотка

Антиоксическая сыворотка — сыворотка крови лошадей, иммунизированных столбнячным анатоксином или токсином.

Титр сыворотки, т. е. количество антиоксических единиц в 1 мл, определяемое при помощи стандартного токсина, не должен быть ниже 250 американских или £00 интернациональных единиц.

Сыворотку употребляют с профилактической и лечебной целью. С профилактической целью вводят подкожно или внутримышечно 1 500 американских или 3 000 интернациональных антиоксических единиц. С лечебной целью вводят внутривенно, внутримышечно, внутримышечно или подкожно £0 000—100 000 и больше антиоксических единиц в зависимости от тяжести заболевания, времени, прошедшего от начала заболевания, и способа введения сыворотки.

Противостафилококковая антиоксическая сыворотка

Противостафилококковая антиоксическая сыворотка — сыворотка крови лошадей, иммунизированных в течение продолжительного времени стафилококковым токсином или анатоксином. В ней содержится стафилококковый антиоксин.

Минимальный титр сыворотки, т. е. допустимое минимальное количество антиоксических единиц в 1 мл, не установлен.

Сыворотку назначают с лечебной целью.

Количество антиоксических единиц, вводимое с лечебной целью, колеблется от 5 000 до 10 000, смотря по характеру заболевания, времени, прошедшему от начала заболевания, и способу введения сыворотки.

Препарат вводят подкожно, внутримышечно или интравенозно.

ВАКЦИНЫ (ПО ФАРМАКОПЕЕ ИЗДАНИЕ VIII 1952 г.)

Вакцинами называют препараты, приготовленные из микроорганизмов — возбудителей той или иной инфекционной болезни, или приготовленные из продуктов жизнедеятельности этих микроорганизмов.

Основной целью применения вакцин является создание невосприимчивости, или иммунитета, к какой-либо инфекционной болезни, что обуславливается усилением защитных свойств организма вследствие появления в крови веществ, носящих название антител. Одни из антител действуют нейтрализующе на яды (токсины), выделяемые микробами в организме больного, другие же ведут к гибели самих микроорганизмов.

Большинство микробных вакцин представляет собой взвеси из убитых микробов, но имеются вакцины, состоящие из взвеси живых микробов, ослабленных теми или иными методами.

Для иммунизации против заболеваний, вызываемых фильтрующимися вирусами (еще более мелкими микроорганизмами, нежели бактерии), вакцины изготовляют из пораженных элементов ткани животного, зараженного соответствующим вирусом. Сюда относятся оспенный детрит, состоящий из вещества оспенных пустул коров или телят и содержащий ослабленный вирус оспы, и антирабическая вакцина, состоящая из тканевых элементов мозга кролика, пораженного вирусом бешенства, ослабленного теми или иными физическими или химическими методами.

Вакцины, приготовленные из нескольких штаммов культур, выделенных от нескольких больных соответствующей инфекцией,

носят название поливалентных вакцин в отличие от моновалентных вакцин, какими являются аутовакцины, изготавливаемые из культуры, . выделенной из одного штамма микроба. Культуры для приготовления вакцин готовят выращиванием на питательных средах из агар-агара или бульона. Выращенные культуры затем умерщвляют воздействием или температуры (56—60°), или химических веществ (фенол, формалин, эфир).

Взвеси убитых микробов разводят физиологическим раствором поваренной соли до определенного содержания микробных тел в 1 мл по оптическому стандарту госконтроля.

Испытание вакцины. Вакцины испытывают: 1) на стерильность, т. е. отсутствие роста при посеве ее на питательные среды; 2) на соответствие определенному для каждого вида вакцин стандарту; 3) на безвредность путем прививки животному.

Этот контроль осуществляют сначала на производстве, а затем в Государственном научно-контрольном институте.

По внешнему виду вакцины, приготовленные из взвеси микробных тел, представляют собой равномерно мутную белесоватую жидкость со слабым желтоватым или сероватым оттенком.

Микробные тела при хранении вакцины могут оседать на дно ампулы в виде беловатого осадка, над которым остается бесцветный физиологический раствор. Осевшая взвесь при встряхивании ампулы должна давать равномерную муть.

Каждую ампулу вакцины снабжают этикеткой. На этикетке обозначают: название института, название вакцины, номер серии, дозу, время изготовления, количество микробных тел в 1 мл (стандарт), номер госконтроля и срок годности. Помимо того, ампулу завертывают в печатное наставление по употреблению данной вакцины.

Признаки негодности вакцины. Изменение нормального внешнего вида, т. е. изменение цвета, резкое помутнение или, наоборот, просветление, наличие посторонних частиц (например, плесени), наличие комочков, не разбивающихся при встряхивании ампул, нарушение целостности ампул, отсутствие этикетки.

Хранение. Вакцины сохраняют в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2° до +10°.

Помимо вакцин, для подкожных прививок применяют вакцины для прививок через рот. Эти вакцины (тифозная, холерная, дизентерийная, туберкулезная) готовят также из убитых микробов или в виде жидких вакцин, подобных подкожным вакцинам, но с большим содержанием микробов в 1 мл, или в виде таблеток, которые состоят из микробов, высушенных при температуре не выше 45°, и наполнителя.

Кроме того, бактериальные вакцины разделяют на простые вакцины, или моновакцины, если вакцина приготовлена из культур одного вида возбудителя болезни (например, брюшнотифозная вакцина), и сложные, если в состав вакцины входят возбудители нескольких болезней, причем при возбудителях двух болезней (например, тиф и паратиф В) вакцина получает название дивакцины, трех (например, тиф, паратиф В и паратиф А) — тривакцины, четырех — тетравакцины и т. д.

Помимо профилактических прививок, вакцины применяют и с лечебной целью, например, гонококковую вакцину, стафилококковую, коклюшную вакцину.

Кроме вакцин, состоящих из микробных тел, применяют препараты, приготовляемые из продуктов жизнедеятельности микробов — токсинов, антитоксинов и антивирусов.

Эти препараты получают путем фильтрования бульонных 8—15-суточных культур. Микробные тела остаются на фильтре, а продукты их жизнедеятельности проходят в фильтрат. Скарлатинозно-стрептококковый токсин применяют для прививок в разведенном виде, а дифтерийный и столбнячный токсины обрабатывают формалином при 40° в течение 21—ЕО дней. В результате такой обработки токсины теряют ядовитость.

Полученные препараты называют **анатоксинами** и применяют для прививок против соответствующих инфекций.

Эти препараты после приготовления подвергают контролю, помимо стерильности и безвредности, на наличие иммунизирующих свойств в опытах на животных и титруют по стандартным сывороткам. Титры обозначают в виде иммунизирующих единиц (ИЕ).

Анатоксины, как и бактериальные вакцины, подлежат государственному контролю.

Признаки негодности и хранение такие же, как и у вакцин.

В последние годы стали применять так называемые **ассоциированные вакцины**, составленные из микробных вакцин и анатоксинов, например, из вакцин брюшного тифа и паратифа В и столбнячного анатоксина.

Прививки этими вакцинами вызывают одновременную выработку иммунитета к нескольким инфекциям, как показали эксперименты на животных и в эпидемиологическом опыте.

Антивирусы — фильтраты многодневных бульонных культур микробов, в которых эти микробы больше не размножаются. Без дальнейшей обработки и после контроля на стерильность применяются в виде примочек и компрессов для лечения, гнойных заболеваний (стрептококковых и стафилококковых) или в виде орошения носоглотки (гриппозный антивирус). Срок годности — 2 года со дня изготовления.

Внешний вид описанных препаратов, за исключением ассоциированных вакцин, — прозрачная жидкость различных оттенков желтого цвета (в зависимости от цвета питательного бульона). Наличие муты указывает, на порчу препарата.

Бактериофаги представляют собой препараты, вызывающие растворение (лизис) соответствующих микробов. Эти препараты получают из живых микробов путем воздействия на них специфического лизирующего (бактериофаг) начала, природа которого в настоящее время еще не является окончательно установленной.

Бактериофаги применяют как для профилактических, так и для лечебных целей.

Широко применяют в настоящее время дизентерийный бактериофаг; имеются и другие бактериофаги — холерный, брюшнотифозный, стрептококковый, стафилококковый.

Все бактериофаги против кишечных инфекций применяют внутрь. Бактериофаги представляют собой прозрачную жидкость, цвет которой зависит от присутствия питательного бульона, придающего тот или иной желтый оттенок препарату. Признак негодности — помутнение. Сохраняют так же, как и вакцины.

Бруцеллезная вакцина

Состоит из взвешенных в физиологическом растворе убитых нагреванием микробов — возбудителей бруцеллеза. Вводится подкожно, внутривенно или внутримышечно.

Дозировка от 10 млн. до 10 млрд. микробных тел.

Срок годности — 1 год.

Холерная вакцина

Холерная вакцина представляет собой взвесь холерных вибрионов в физиологическом растворе поваренной соли, убитых нагреванием или формалином, с содержанием 4 млрд. микробных тел в 1 мл.

Применяют подкожно. Взрослым делают 3 прививки в дозах 0,5—1—1 мл подкожно с интервалом в 7—10 дней. Детям вводят меньшую дозу пропорционально их возрасту ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{8}$ дозы взрослого).

Срок годности — 2 года со дня разливки. После истечения этого срока вакцина подлежит уничтожению.

Жидкая дизентерийная вакцина

Жидкая дизентерийная вакцина представляет собой взвесь в физиологическом растворе убитых дизентерийных микробов Григорьева — Шига — Флекснера с содержанием 10 млрд. микробных тел в 1 мл.

Дозировка — 10 мл внутрь натошак 3 дня подряд. Таким образом, полная вакцинирующая доза для взрослого 300 млрд. микробных тел.

Срок годности — 2 года со дня разливки.

Примечание. Кроме всех данных, на этикетке должно быть указано: «Годна только для внутреннего употребления».

Сухая дизентерийная вакцина в таблетках

Дизентерийные таблетки состоят из убитых формалином микробов дизентерии.

Каждая таблетка весом от 0,1 до 0,3 г содержит 100 млрд. убитых микробов.

Таблетки с профилактической целью принимают 3 раза натошак по 1 таблетке в день; дети до 7 лет принимают по половине таблетки.

Сохраняют дизентерийную вакцину в хорошо закупоренных байках, залитых смолкой, в сухом, защищенном от света месте. Срок годности — 10 лет.

Гонококковая вакцина

Поливалентная гонококковая вакцина представляет собой взвесь в физиологическом растворе гонококков, выращенных на плотной среде и убитых нагреванием или прибавлением раствора формалина. Выпускают вакцину со стандартом 200—Е00 млн. и до 1 млрд. микробных тел в 1 мл.

Срок годности — 1 год (гретая) или 6 месяцев (формалиновая).

Примечание. Кроме обычного испытания, вакцину испытывают в клинике для установления начальной терапевтической дозы, которую указывают на этикетке.

Менингококковая вакцина

Поливалентная менингококковая вакцина представляет собой взвесь в физиологическом растворе возбудителя эпидемического менингита. Вакцину изготавливают из свежeweделенных культур менингококков различных типов, убитых нагреванием или прибавлением формалина.

Стандарт — 1 млрд. микробных тел в 1 мл.

Применяют для лечения в случаях хронического заболевания.

Начальная лечебная доза от 0,1 до 0,2 мл.

Срок годности — 1 год.

Коклюшная вакцина

Коклюшная вакцина состоит из взвеси убитых коклюшных микробов в физиологическом растворе.

В 1 мл содержится 10 млрд. микробных тел.

Вакцину применяют для лечебных и диагностических целей.

Начальная доза для детей до 1 года — 0,3 мл; для детей старше 1 года — 0,5 мл. Последующие дозы увеличивают в 1%—2 раза.

Инъекции производят под кожу с промежутками в 2—3 дня.

Срок годности — 2 года.

Чумная вакцина

Чумную вакцину изготавливают из убитых нагреванием или ослабленных живых микробов возбудителей чумы и применяют исключительно для профилактики этой инфекции.

В настоящее время употребляют вакцины четырех типов.

1. АД — вакцина, представляющая собой взвесь микробов в сахарном растворе. Дозировка 0,5—1—1,5 мл с промежутками в 4—7 дней.

2. Вакцина по Колле — убитая взвесь микробов в физиологическом растворе. Дозировка 0,5—1,5 мл с промежутками в 3—5 дней.

3. Вакцина Хавкина — шестинедельная убитая бульонная культура. Дозировка 0,5—1,5 мл с промежутками в 3—5 дней.

4. Живые вакцины из авирулентных штаммов чумных бактерий.

Сохраняют вакцину при температуре не выше +4° в сухом, защищенном от света месте. Срок годности — 1/4 года.

Антирабическая вакцина (вакцина против бешенства)

Антирабическую вакцину применяют для прививок против заболевания бешенством людей, укушенных бешеными или подозрительными на бешенство животными, а также при попадании слюны этих животных на кожу и слизистые оболочки.

Материалом для вакцины служит измельченный головной и спинной мозг кролика, зараженного фиксированным вирусом бешенства.

Наиболее принятыми в настоящее время являются вакцины Филиппа и Ферми.

1. Вакцина Филиппа представляет собой десятикратное разведение измельченного мозга стерильным, нейтральным глицерином. Перед употреблением глицериновую эмульсию мозга разводят в 20—25 раз физиологическим раствором, который прилагают в соответствующем количестве к рассылаемой вакцине.

Разведенную вакцину впрыскивают ежедневно под кожу живота в дозах от 0,25 до 2,5 мл.

Срок годности — 1/2 месяца со дня изготовления и 20 дней со дня отсылки на прививочный пункт.

При укусах назначают 20—30 прививок, при ослонении — 12—15 прививок. При тяжелых укусах назначают повторный курс прививок.

2. Вакцина Ферми представляет собой 5% разведение измельченного мозга в физиологическом растворе, содержащем 1% фенола.

Прививки производят под кожу живота ежедневно в дозе от 1 до 3 мл. При тяжелых укусах делается две прививки в день.

В зависимости от тяжести укусов назначают 20—25 и более прививок; при ослонении — 15 прививок.

Обе вакцины сохраняют в защищенном от света месте при температуре от +5° до +8°. Хранение при комнатной температуре недопустимо. Срок годности — 5 месяцев.

Примечание. Следует избегать замораживания вакцины. В случае замерзания, если нет другой вакцины, можно начать прививки оттаявшей, но для продолжения прививок необходимо срочно получить свежую вакцину.

Перед употреблением вакцину необходимо встряхивать.

Комбинированная скарлатинозная вакцина

Комбинированная скарлатинозная вакцина содержит в 1 мл 2 000 кожных доз скарлатинозного токсина и 1 млрд. убитых скарлатинозных стрептококков.

Прививки вакциной производят под кожу троекратно. Срок годности — 2 года.

Стафилококковая вакцина

Стафилококковая вакцина представляет собой взвесь в физиологическом растворе убитых нагреванием или формалином свежесодержанных стафилококков от больных.

Стафилококковую вакцину выпускают со стандартом 1 млрд. микробных тел в 1 мл.

Начальная терапевтическая доза 0,2 мл подкожно. Затем дозу повышают в зависимости от реакции. Интервалы между прививками от 8 до 12 дней в зависимости от исчезновения реакции на предыдущую прививку.

Срок годности — 2 года.

Стрептококковая поливалентная вакцина

Стрептококковая вакцина представляет собой взвесь убитых стрептококков в физиологическом растворе.

Вакцину изготовляют из нескольких культур стрептококков, выделенных от больных различными болезнями стрептококкового происхождения. В 1 мл содержится 1 млрд. микробных тел.

Начальная доза 0,1—0,3 мл с увеличением в последующих прививках на 0,2 мл.

Перед употреблением ампулы с вакциной следует встряхивать.

Срок годности — 2 года.

Туберкулезная вакцина БЦЖ

Вакцина готовится из взвеси живой аэроулетной культуры туберкулезных бактерий (штамм БЦЖ).

Д. Жидкая вакцина разливается в ампулы по одной дозе (2 мл).

Вакцина хранится в темном месте при температуре от +2° до +10°.

Срок годности — 15 дней со дня изготовления.

Б. Сухая вакцина состоит из высушенной в вакууме взвеси живой культуры БЦЖ. Непосредственно перед употреблением разводится кипяченой остуженной водой (недистиллированной) из расчета 2 мл воды на 1 дозу вакцины.

Сухая вакцина хранится при температуре не выше +8° в темном месте.

Срок годности — 1 год.

Туляремиальная вакцина

Готовится из живых ослабленных по методу Гайского культур туляремиальных микробов.

Для подкожных прививок применяют взвесь туляремиальных микробов в физиологическом растворе с содержанием 50 млн. (вакцина I из более ослабленных микробов) или 25 млн. микробов (вакцина II из более вирулентного штамма) в 1 мл. Для детей готовится вакцина из штамма I, содержащая 10 млн. микробов в 1 мл.

Срок годности — 20 дней.

Хранение. Хранится при температуре 0—2°. Вакцина для накожных прививок по методу Эльберта представляет живую культуру штамма Гайского в желточной среде.

Срок годности при хранении в темном прохладном месте — 3 месяца.

Тетравакцина (тиф, паратиф А и Б и холера)

Тетравакцина представляет собой взвесь в физиологическом растворе убитых микробов с содержанием 3 млрд. микробных тел в 1 мл (2 млрд. холерных, 500 млн. тифозных, 250 млн. паратифозных А и 250 млн. паратифозных Б).

Применяют подкожно.

Дозировка для взрослого 1—2—2 мл с интервалами между прививками в 7—10 дней. Детям вводят меньшую дозу соответственно их возрасту.

Срок годности — 2 года.

Дивакцина (тиф и холера)

Дивакцина (тиф и холера) представляет собой взвесь в физиологическом растворе тифозных и холерных микробов, убитых нагреванием, с содержанием по 2,5 млрд. микробных тел в 1 мл (2 млрд. холерных и 500 млн. тифозных).

Применяют подкожно для профилактики заболеваний брюшным тифом и холерой.

Дозировка для взрослого 0,5—1 мл подкожно с интервалами между прививками в 5—7 дней. Детям вводят меньшую дозу соответственно их возрасту.

Срок годности — 1 % года со дня разливки, после истечения которого вакцина подлежит уничтожению.

Тривакцина (тиф и паратиф А и Б)

Тривакцина (тиф и паратиф) А и Б) представляет собой взвесь в физиологическом растворе тифозных и паратифозных А и Б микробов, убитых нагреванием или прибавлением формалина, с содержанием по 1,5 млрд. микробных тел в 1 мл (1 млрд. тифозных и по 250 млн. паратифозных А и Б).

Применяют подкожно.

При первичной прививке делается 3 инъекции в дозах для взрослых 0,5—1—1 мл с интервалами в 7—10 дней. Детям вводят меньшую дозу соответственно их возрасту. При следующих прививках число инъекций сокращают на второй год до двух, на третий год и далее — до одной.

Срок годности — 2 года.

Дивакцина (тиф и паратиф Б)

Дивакцина представляет собой взвесь тифозных и паратифозных Б микробов в физиологическом растворе, убитых нагреванием или прибавлением раствора формалина, с содержанием по 1,5 млрд. микробных тел в 1 мл (1 млрд. тифозных и 500 млн. паратифозных Б).

Дивакцина, в которой взвесь микробных тел предварительно обработана формалином, содержит 3 млрд. микробных тел в 1 мл (2 млрд. тифозных и 1 млрд. паратифозных Б),

Применяют подкожно.

Дозировка для взрослого — 0,5—1 мл под кожу с интервалами в 7—10 дней.

Детям вводят меньшую дозу соответственно их возрасту. Срок годности — 2 года.

Оспенный детрит

Оспенный детрит состоит из измельченного и разведенного глицирином материала оспенных пустул телят, содержащих живой вирус коревой оспы.

Детрит выпускают после прохождения двух видов контроля: 1) бактериологического, обеспечивающего отсутствие опасных для человека микробов, и 2) контроля прививающей силы путем титрования его на опытных животных, а также пробной вакцинации.

После прохождения контроля детрит разливают в капилляры по 2—5—10 доз или в маленькие флаконы на 25—50—100 доз. Детрит имеет вид гомогенной эмульсии серовато-белого цвета.

Сохраняют оспенный детрит на леднике или в холодильнике при температуре от +2° до +6°.

При хранении в комнатной температуре детрит теряет активность; солнечный свет также вредно действует на активность детрита. Детрит должен расходоваться в пределах срока годности соответственно указанию на этикетке.

Для пересылки в теплое время года охлажденный, детрит должен пересылаться в условиях сохранения низкой температуры. ■

Пентавакцина

Пентавакцина представляет сложный препарат, состоящий из убитых микробов брюшного тифа, паратифов А и Б, дизентерии Шига и Флексера. В 1 мл вакцины содержится 1 млрд. тифозных, по 250 млн. паратифозных и по 750 млн. дизентерийных микробов.

Дозировка для взрослых 0,5—1—1 мл с интервалами в 7—10 дней (допускается их увеличение до 20 дней). Детям, в зависимости от возраста, вводится $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{3}$ дозы взрослого.

Срок годности — 2 года.

«

Поливакцина

Препарат содержит полные антигены тифозного, паратифозных А и Б, холерного, дизентерийного микробов и столбнячный анатоксин. Представляет желтоватую жидкость с аморфным белым осадком фосфата кальция, легко распределяющимся в жидкости при встряхивании.

Срок годности при хранении в условиях температуры не ниже +10° — 1 год.

Вакцина не годна, если в ампуле выпал кристаллический неразвивающийся осадок в преобладающем над аморфным количестве.

Дизентерийный бактериофаг

Дизентерийный бактериофаг представляет собой бульонную культуру дизентерийных микробов, растворенных под влиянием литического агента — бактериофага. Препарат должен быть совершенно прозрачным.

Бактериофаг должен обладать определенной силой, т. е. растворять дизентерийные микробы, будучи разведенным не менее чем в 10 млн. раз, что отмечают на этикетке цифрой Ю'.

Обычно дизентерийный бактериофаг выпускают с титрами не менее 10¹⁰.

С профилактической целью применяют трехкратно с промежутками в 5—7 дней в следующей дозировке: детям от 6 месяцев до 3 лет — по 5 мл на прием, детям старше 3 лет и взрослым — по 10 мл на прием.

С лечебной целью бактериофаг назначают 2—3 раза в сутки в дозировке: детям до 3 лет — до 5 мл на прием, детям старше 3 лет и взрослым — по 10—15 мл на прием.

Срок годности — 1 год с момента изготовления. По прошествии этого срока бактериофаг подлежит повторной проверке в производственном бактериологическом институте и государственном научно-контрольном институте. При сохранении титра срок годности данной серии удлиняют на 6 месяцев.

Примечание. Испытание и другие данные см. статью «Вакцина».

СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (СУЛЬФАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СУЛЬФОНАМИДЫ)

Открытие химиотерапевтического действия сульфаниламидных соединений несомненно явилось одним из /ценнейших плодов систематической работы исследователей. Первый сульфаниламидный препарат, впоследствии названный белым стрептоцидом (*vi, был синтезирован еще в 1908 г. (в интересах текстильной промышленности), антимикробные же свойства этих соединений были обнаружены лишь в 1935 г. Можно без преувеличения сказать, что сульфаниламидные препараты принесли спасение миллионам больных людей.

В Советском Союзе особенно много по синтезу сульфаниламидных препаратов было сделано во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте (ВНИХФИ) под руководством О. Ю. Магидсона и И. Я. Постовского. Все сульфаниламидные препараты (кроме красного стрептоцида) представляют собой белые или слегка желтовато-белые без запаха и вкуса кристаллические порошки, которые без разрушения переносят нагревание до 140—150°, но при более высокой температуре разлагаются и обесцвечиваются. Они мало растворимы в воде, более растворимы в водных растворах щелочей (кроме дисульфана и сульгина). Многие сульфаниламидные препараты имеются в виде натриевых солей, легко растворимых в воде.

Сульфаниламиды можно разделить на две группы: преимущественно резорбтивного (общего) и преимущественно местного действия.

Разделение это условно, так как некоторые препараты первой группы применяются и для местного действия (белый стрептоцид, сульфидин, норсульфазол и др.) и, наоборот, некоторые препараты второй группы (сульфацил) используются нередко для общего действия.

А. Препараты, применяемые преимущественно для общего действия

1. **Белый стрептоцид** (*Streptocidum album*) — мелкокристаллический порошок белого цвета, без запаха, растворимый в воде до 0,8%. Обладает избирательным бактериостатическим действием по отношению к ряду микробов: стрептококку, стафилококку, менингококку, гонококку, пневмококку, кишечной палочке и др. Применяется против стрептококковых заболеваний: рожи, тяжелых тонзиллитов, послеродового сепсиса, стрептококковой ангины, острой и хронической гонорреи, а также при лечении колибациллярных заболеваний: цистита, пиелита, колита.

Взрослым назначают по 0,5—1,0 на прием несколько раз в день, не больше 7,0 в день.

Снаружи применяется в виде пудры по 5,0—1⁰,0 на рану или вдувается в рану в той же дозе.

Высшая разовая доза 2,0.

Высшая суточная доза 7,0.

2. **Красный стрептоцид** (*Streptocidum rubrum*) — мелкокристаллический порошок кирпично-красного цвета, без запаха, растворимый в 400 частях воды. Применяется преимущественно для лечения стрептококковых инфекций (рожа, стрептококковый сепсис, пиелиты, ангины и др.). Взрослым назначают внутрь по 0,3 на прием несколько раз в день до 3,0—4,0.

Детям назначают по 0,1—0,2 на прием до 0,5—1,0 в сутки.

В тех случаях, когда состояние больного не позволяет назначить препарат внутрь (бессознательное состояние, рвота и пр.), можно вводить под кожу или внутримышечно.

Для инъекции красный стрептоцид назначают по 20 мл 0,25% раствора 2—3—5 раз в день.

3. **Сульфидин** (*Sulfidinum*) — белый или слегка желтоватый порошок, без запаха, мало растворимый в воде (1 : 1 000). Применяется для лечения пневмококковых, гонококковых, менингококковых и колибациллярных инфекций. При этих заболеваниях сульфидин значительно эффективнее белого и красного стрептоцида.

Хорошо действует при лечении дизентерии, колитов, острых гастроэнтеритов. Однако в настоящее время при этих заболеваниях применяются дисульфан, сульгин и фталазол.

Сульфидин, как и другие сульфаниламиды (белый стрептоцид, сульфазол, норсульфазол, дисульфан и др.), действует бактериостатически, т. е. сульфидин не убивает микробов, а только прекращает их рост и размножение.

Наибольшая эффективность сульфидина обнаруживается при приеме его в первые часы заболевания.

По инструкции Наркомздрава СССР от 23/V 1840 г. при крупозной пневмонии взрослых сульфидин рекомендуется назначать круглые сутки по следующей схеме:

1-е	сутки	лечения	сразу	2,0,	затем	по	1,0	через	каждые	4	часа
2-е	»	»	»	по	1,0	через	каждые	6	часов		
3-й	»	»	»	1,0	»	»	»	6	часов		
4-е	»	»	»	1,0	»	»	»				
6-е	»	»	»	0,5	»	»	»	6			

В среднем для лечения каждого случая крупозной пневмонии требуется 21,0—22,0 сульфидина.

При цереброспинальном менингите у детей рекомендуется следующая схема лечения сульфидином:

Возраст				0,2	0,25	0,5	1,0	1,5	2,0
1—6 месяцев . . .	0,2 X4	0,2 X4	0,15X4	0,15X4	0,15X4	0,15X4	0,15X4	0,15X4	0,15X4
6 месяцев—1 год	0,25X4	0,25 X4	0,2 X4	0,2 X4	0,2 X4	0,2 X4	0,2 X4	0,2 X4	0,2 X4
1—2 года	0,3 X4	0,3 X4	0,25 X4	0,25 X4	0,25 X4	0,25 X4	0,25 X4	0,25 X4	0,25 X4
2½—5 лет	0,4 X4	0,4 X4	0,4 X4	0,4 X4	0,4 X4	0,4 X4	0,4 X4	0,4 X4	0,4 X4
5—7 лет	0,5 X4	0,5 X4	0,5 X4	0,5 X4	0,5 X4	0,5 X4	0,5 X4	0,5 X4	0,5 X4
7—12 лет	0,6 X4	0,6 X4	0,6 X4	0,6 X4	0,6 X4	0,6 X4	0,6 X4	0,6 X4	0,6 X4
12—16 лет	0,8 X4	0,8 X4	0,8 X4	0,8 X4	0,8 X4	0,8 X4	0,8 X4	0,8 X4	0,8 X4
Старше 16 лет . . .	1,0 X6	1,0 X6	1,0 X6	1,0 X6	1,0 X6	1,0 X6	1,0 X6	1,0 X6	1,0 X6

При лечении бронхопневмонии для детей рекомендуется следующая дозировка:

До 3 месяцев	0,1	4
3—6 »	0,1	4
6—12 »	0,1	4
1—3 года	0,1	4
3—5 лет	0,1	4
5—7 »	0,1	4
7—12 »	0,1	4
12—15 »	0,1	4

На первый прием дается удвоенная доза.

Сульфидин назначается в первые 2—4 дня каждые 4 часа, затем каждые 6 часов (4 раза в сутки), в последние дни приема 3 раза в сутки.

При гоноррее: в 1-й день по 0,5 8 раз в день, во 2-й день по 0,5 8 раз в день, в 3-й и последующие дни по 0,5 6 раз в день. На курс лечения требуется около 17,0—20,0 сульфидина.

При лечении сульфидином запрещается назначение сернокислой слабительной соли (образование сульфогемоглобина), а также применение УКВ (ультракоротких волн), кварца и частого рентгенологического исследования.

II

При лечении сульфидином необходимо регулярно (не реже чем через день) производить анализ крови (содержание гемоглобина, лейкоцитов) и анализ мочи (степень диуреза, кровяной пигмент).

При лечении сульфидином возможны побочные явления: потеря аппетита, тошнота, рвота, гематурия, образование в крови сульфогемоглобина и метгемоглобина, цианоз, анемия, лейкопения.

В качестве противотоксического средства при развитии побочных явлений рекомендуется применение никотиновой и аскорбиновой кислоты. Для лучшего выведения сульфидина из организма — обильное питье (2—2,5 л жидкости в сутки), особенно со щелочами (содой).

Сульфидин, так же как сульфазол и белый стрептоцид, может быть использован для местного лечения инфицированных ран (присыпка, вдувание порошка, эмульсия).

Однако надо учитывать, что омертвевшие ткани богаты антисульфамидными веществами (продукты распада, парааминобензойная кислота и др.), которые могут тормозить действие сульфамидных препаратов. Поэтому необходима предварительная хирургическая обработка раны с целью удаления некротизированных тканей.

Высшая разовая доза 2,0.

Высшая суточная доза 7,0.

4. Сульфазол (Sulfazolum) — белый кристаллический порошок, мало растворимый в воде.

Применяется при лечении крупозной пневмонии, менингита, гонорреи. Назначается внутрь в тех же дозах, что и сульфидин.

В отличие от сульфидина сульфазол лучше переносится больными (реже тошнота, рвота).

Однако при длительном лечении, так же как и при других сульфаниламидных препаратах, требуется наблюдение за составом крови (анемия, лейкопения) и мочи (гематурия). Необходимо рекомендовать обильное питье (до 2—2,5 л воды в сутки).

Высшая разовая доза 2,0.

Высшая суточная доза 7,0.

5. Норсульфазол (Ndrsulfazolum) — белый кристаллический порошок без запаха и вкуса, плохо растворимый в воде. Натриевая соль норсульфазола хорошо растворима в воде. Химический эффект норсульфазола в отношении пневмококков, гонококков, гемолитического стрептококка не уступает сульфидину и сульфазолу, а в отношении стафилококка даже выше. Ацетилирование норсульфазола меньше, чем сульфидина и сульфазола, что создает меньшую опасность выпадения его в мочевых путях и образования сульфаниламидных кристаллов.

Норсульфазол менее токсичен, чем сульфазол; его побочные действия (тошнота, осложнения со стороны мочевых путей, крови) появляются реже и в меньшей степени, чем при применении сульфазола и сульфидина.

Показания к применению те же, что и для сульфидина и сульфазола (пневмония, цереброспинальный менингит, гоноррея, стафилококковый менингит, стрептококковый сепсис и пр.).

Дозировка: при пневмонии и менингите назначают внутрь на первый прием 2,0, а потом по 1,0 через каждые 4 часа до падения

температуры; в дальнейшем по 1,0 через 6 и 8 часов; всего на курс лечения 24,0—30,0 норсульфазола.

При стафилококковых инфекциях на первый прием 3,0—4,0, а потом по 1,5 через каждые 4 часа.

При гонорее по 1,0 5 раз в день, а потом по 1,0 4 раза в день, всего 6—9 дней.

При применении норсульфазола необходимо поддерживать усиленный диурез введением в организм в день до 2—3 л жидкости.

Для внутривенного введения применяются 10—20% растворы натриевой соли норсульфазола.

6. Сульфазин (Sulfazinum) — белый кристаллический порошок, плохо растворимый в воде.

Применяется для лечения стрептококковой инфекции. Сульфазин менее токсичен, чем белый стрептоцид, сульфидин, сульфазол. Дозы сульфазина такие же, как и сульфазола, т. е. в острых случаях первоначальная доза 2,0—3,0, а потом по 1,0 через каждые 4 часа.

7. Сульфацил (Sulfacilum) — белый кристаллический порошок, растворимый в 200 частях воды, натриевая соль его легко растворима в воде. Оказывает выраженный терапевтический эффект при стрептококковых, гонококковых, пневмококковых инфекциях; при этих инфекциях он уступает по активности сульфидину и сульфазолу, но активнее других сульфаниламидных препаратов при стафилококковой инфекции.

Сульфацил весьма эффективен для лечения инфицированных ран мягких тканей и костей (5—10% растворы, присыпки, мази).

Растворимый сульфацил особенно рекомендуется для лечения бленнореи новорожденных и инфицированных язв роговицы (10—20—30% растворы, а также per se).

Высшая разовая доза 2,0.

Высшая суточная доза 7,0.

8. Сульфадимезин (Sulfadimezinum) — светложелтый кристаллический порошок, трудно растворимый в воде. Сульфадимезин применяется при стрептококковых, менингококковых и гонококковых инфекциях в следующих дозах: на первый прием 3,0—4,0, а потом по 1,0 каждые 8 часов до падения температуры и в течение последующих трех суток.

Детям назначают в соответствии с возрастом:

До 6 месяцев	0,5	первая	доза и по 0,25	каждые 12 часов
От 6 до 12 месяцев	1,0	»	» » 0,5	» 12 »
До 10 лет	1,5	»	» » 1,0	» 12 »

Сульфадимезин легко проникает в спинномозговую, плевральную и перитонеальную жидкость. Он хорошо переносится и редко дает осложнения со стороны мочевых путей.

Б. Препараты, применяемые преимущественно для местного действия

1. Дисульфан (Disulfanum) — белый мелкокристаллический порошок, мало растворимый в воде, медленно всасывается кишечником и медленно выделяется мочой.

Применяется при бациллярной дизентерии и гонорее. Побочным токсическим действием препарат почти не обладает, хорошо переносится как взрослыми, так и детьми.

Взрослым назначают внутрь по 0,5—1,0 3—4 раза в день. На курс лечения 5,0—12,0.

Детям до 1 года *0,1—0,2 па 1 кг веса ребенка в сутки через 4—6 часов в течение 8—10 дней.

Высшая разовая доза 2,0.

Высшая суточная доза 7,0.

2. Сульгин (Sulgmum) — белый порошок без вкуса и запаха, плохо растворимый в воде, медленно всасывается кишечником. Сульгин мало токсичен. Хорошо переносится и является одним из наиболее эффективных сульфаниламидных препаратов при бациллярной дизентерии, язвенном колите, гастроэнтерите. Иногда отмечаются побочные нежелательные явления: кожные сыпи, в редких случаях выпадение в мочевых путях ацетилированного сульгина. Рекомендуется во время лечения поддерживать усиленный диурез (введение в организм 2—3 л воды в день).

Рекомендуется следующая схема лечения сульгином:

В 1-й день	лечения	по 2,0	6 раз	в день
На 2-й	»	»	2,0	5 » » »
» 3-й	»	»	2,0	5 » » »
» 4-й	»	»	2,0	4 раза » »
» 5-й	»	»	2,0	3 » » »

Курс лечения продолжают 5—7 дней.

*На курс лечения расходуют 40,0—50,0 сульгина.

Лечебный эффект отмечается уже на первые-вторые сутки. В хронических случаях сульгин вводят в клизмах ежедневно по 7,0 в 200 мл теплой воды 7 дней подряд.

3. Фталазол (Phthalazolium) — белый мелкокристаллический порошок, нерастворимый в воде. Препарат крайне слабо всасывается желудочно-кишечным трактом. Основная масса препарата остается в кишечнике. С калом выделяется только 50% препарата.

4. Препарат мало токсичен и отличается большой активностью по отношению к возбудителям кишечных инфекций.

Химиотерапевтическая активность его по отношению к кишечной флоре выше, чем у других сульфаниламидных препаратов. Применяется для лечения дизентерии и язвенных колитов.

Доза внутрь по 1,0—2,0 4—6 раз в день в первые два дня лечения, а в последующие дни назначают половинные дозы.

Детям фталазол назначают в первые сутки из расчета по 0,2 на 1 кг веса ребенка в сутки. Препарат дают равными дозами каждые 4 часа; в последние дни — по 0,2 в сутки на 1 кг веса ребенка равными дозами каждые 6—8 часов.

Принципы применения сульфонамидов¹

1. Начинать лечение при острых инфекциях надо как можно раньше (когда в организме меньше микробов, не ослаблены его защитные силы, имеется высокая температура, при которой действие сильнее) с назначения большой начальной дозы (чтобы возможно скорее в крови образовалась действующая концентрация).

2. Достаточную концентрацию в крови необходимо поддерживать круглые сутки, особенно в остром периоде заболевания (поэтому, если нет серьезных противопоказаний, больного следует будить ночью, чтобы он припал во-время сульфонамид). Следует иметь в виду, что при очень тяжелой инфекции требуется большая концентрация в крови (следовательно, и большая доза), чем при инфекции средней степени.

3. Частота приема (обычно через 4 часа) должна быть точно соблюдена, так как она обусловлена быстротой всасывания и выделения сульфонамида.

4. При получении общего улучшения и падении температуры до нормальной следует продолжать давать сульфонамиды в несколько меньших (но не слишком малых) дозах еще 2—3 дня (во избежание рецидива заболевания). Не следует сульфонамиды давать слишком долго (опасность осложнений). Обычно длительность лечения равна 6—7 дням (редко больше). Если при достаточных дозах нет определенного улучшения через 3—4 дня, следует применить более сильный сульфонамид или прекратить лечение сульфонамидами ввиду малой чувствительности к ним возбудителя болезни.

5. При подострых и хронических инфекциях первая доза не должна быть больше, чем последующие. При инфекциях мочевых путей дозы должны быть меньше, чем при общих инфекциях (ввиду концентрирования сульфонамидов в моче при выделении).

6. Выпускаемые в продажу таблетки (0,25 и 0,5) сульфонамидов не указывают на величину доз для однократного приема; они лишь удобны для составления различной величины доз на прием (от 0,25 до 1,0 у детей и от 0,5 до 2,0 у взрослых). Таблетки перед приемом следует размельчить; во избежание рвоты (особенно при приеме сульфидина) порошок следует принимать в молоке, слизи, воде или, лучше, в 15—30 мл смеси, содержащей в 30 мл по 1,0 бикарбоната натрия и цитрата натрия. После приема рот надо полоскать водой, которую затем проглатывают, так как она будет содержать порошок, который пристал к слизистой оболочке рта.

7. При всех препаратах сульфонамидов (кроме белого стрептоцида, сульфацила, сульфадимезина) совершенно необходимо давать нить во время лечения и несколько дней после его прекращения достаточное количество жидкости, в общем до 0,5 л на каждый грамм принимаемого сульфонамида, до 3,5 л в сутки (взрослому); добиваться, чтобы в сутки выделялось более 1,5 л мочи (с целью предохранить от выпадения кристаллов в мочевых путях). С той же целью следует давать по 1,0—1,5 бикарбоната натрия и 1,0—1,5 цитрата натрия при приеме каждой дозы сульфонамида (кроме

сульфидина), чтобы моча стала щелочной (проба на лакмус). Детям щелочи дают в меньших дозах.

Во время всего лечения необходимо тщательно измерять температуру. Если лечение длится более 7 дней, 2 раза в неделю необходимо исследовать кровь.

8. Обычно принимают сульфонамиды per os. В вену очень медленно вводят растворы натриевых солей сульфонамидов, когда желательно быстро создать высокую концентрацию в крови (например, в начале лечения тяжелой инфекции) или когда прием внутрь нельзя провести (например, если у больного рвота или больной в бессознательном состоянии). Эти растворы должны попасть в вену, но не в мышцу (произойдет некроз вследствие высокой щелочности); их ни в коем случае нельзя вводить субокципитально. Иногда вводят в прямую кишку 0,8% раствор белого стрептоцида (в физиологическом растворе или с прибавлением до 1% глюкозы) каждые 4 часа в дозах, несколько больших, чем per os, в 50 мл объема жидкости.

9. При инфекциях средней тяжести или легких часто бывает достаточно сначала дать взрослому 2,0 на прием, а затем по 1,0 через 4 часа 2—3 дня. Для детей моложе года расчет доз идет по весу.

10. При тяжелых инфекциях, чтобы получить наилучшие результаты, следует определять концентрацию сульфонамида в крови по крайней мере 1—2 раза в первые 2—3 дня, так как концентрация в крови может не соответствовать принятой дозе (различное всасывание, ацетилирование, рвота); эти определения очень важны также для установления, нет ли высокой резистентности возбудителя (в этом случае необходимо отказаться от терапии сульфонамидами).

11. Лечение следует немедленно прекратить при наступлении следующих видов побочного (токсического) действия: повышение температуры, слабость, головная боль, боль в горле (подозрение на агранулоцитоз), боль в пояснице, видимая глазом кровь в моче, уменьшение суточного количества мочи ниже 1 л (отложение кристаллов в мочевых путях), уменьшение количества полиморфно-ядерных лейкоцитов ниже 40% или менее у взрослого больного или быстрое падение общего количества лейкоцитов ниже 4 000 в 1 мм³.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

1. Бигумаль (Bigumalum). Белый кристаллический порошок, горького вкуса, растворяется в воде в концентрации 1 : 100 при температуре 20° и в спирту. Водный раствор препарата стоек, не разлагается при кипячении.

Подобно акрихину и хинину, обладает выраженным пщонтоцидным действием и не оказывает явного действия на гаметоиды. По эффективности не уступает акрихину при лечении трехдневной формы малярии и по сравнению с последним обладает следующими преимуществами: отсутствие окрашивания тканей, более высокая эффективность при лечении тропической малярии и способность в малых однократных дозах (0,1 один раз в неделю) предупреждать рецидивы трехдневной малярии. При приеме внутрь бигумаль

¹ Приведено по М. П. Николаеву, Учебник фармакологии, 1948-

быстро всасывается и уже в конце первого часа после приема обнаруживается в моче, медленно выделяется из организма в течение 3—5 суток после его приема. Хорошо переносится взрослыми, детьми и беременными; иногда наблюдается тошнота, рвота, головные боли и появление в периферической крови нейтрофильных миелоцитов.

Назначается внутрь по следующей схеме С в виде пятидневного цикла:

День лечения	Суточная доза	Порядок приема
	0,6 0,3 0,3 0,3 0,3	0,3 два раза в день один раз » » 0,3 » » » 0,3 » » » » 0,3 » » » »

При тропической малярии лечение ограничивается одним пятидневным циклом, так как имеется основание считать, что бигумаль при этой форме малярии оказывает полное терапевтическое и, вероятно, стерилизующее действие (при отсутствии реинфекции).

При трехдневной и четырехдневной малярии бигумаль при 5—10-дневном курсе лечения не предотвращает появления рецидивов, которые возникают в 25—40% случаев. Поэтому при этих формах малярии необходимо после первого цикла продолжать лечение бигумалем по 0,1 г один раз в неделю в течение 3—6 месяцев.

Лечение детей проводится по той же схеме, соответственно приводимым ниже возрастным дозировкам:

Возрастная группа	Суточная доза
До 1 года . . . От 1 года до 2 . 2 » 4 4 » 5	0,025 0,025—0,05 0,05 —0,075 0,075—
> 12» 16	0,1 0,10 —0,15 0,15—0,2 0,2— 0,25—0,3
12 Рф.	
Bigumali 0,2	
D. t. d. N. 15	

S. По 1 порошку 3 раза в день (взрослому) 2. Дибазол (**Dibasolum**). Белый порошок, обладающий сосудорасширяющим и спазмолитическим действием. Испытан с хорошими результатами на большом количестве больных при заболеваниях центральной нервной системы, в основном при полиомиелитах, для лечения которых имеется разработанная инструкция. Курс лечения

состоит из 5—10 приемов препарата в дозе 0,005 по одному порошку в день или через день. Для детей до одного года — 0,001, от одного года до 3 лет — 0,002, от 3 до 8 лет — 0,003, от 8 до 12 лет — 0,004, от 12 лет и старше — 0,005. Назначают его за 2 часа до приема пищи или через 2 часа после приема пищи.

Дибазол показан также при гипертонической болезни в дозе 0,02 2—3 раза в день внутрь или под кожу по 1—2 мл 1% раствора.

Rp. Dibasoli 0,02 Sacchari 0,2 M. f. p. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 2—3 раза в день (при гипертонии)

3. Дикумарин (**Dicumarinum**). Белый кристаллический порошок с ароматическим запахом, горького вкуса, плохо растворимый в воде, хорошо — в щелочных растворах. Содержится в медовом клевере, или доннике. Получается также синтетически.

Применяется как средство, замедляющее свертывание крови при лечении тромбозов и эмболии, когда показан гепарин (антитромбин), перед которым дикумарин имеет преимущества: возможность применения per os и более длительное действие. Назначают внутрь в первый день заболевания по 300 мг, затем ежедневно по 200 мг. Внутривенно вводят двунариевую соль препарата по 4—5 мг на 1 кг веса. Курс лечения — не менее 4 недель.

Противопоказан при язвенных процессах, при кровотечениях, вызываемых недостатком в организме витамина К, при болезнях печени и почек.

Rp. Dicumarini 0,2 D.
f. d. N. 15

S. В первый день по полтора порошка, затем ежедневно по 1 порошку 1 раз в день

4. Димедрол (**Dimedrolum**). Белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде. Расслабляет гладкую мускулатуру, со кротивишуюся под влиянием гистамина, и предотвращает развитие экспериментального анафилактического шока. Во много раз активнее, чем папаверин, нейтрализует гистамин; значительно эффективнее ацетилхолина.

В клинике оказался эффективным при сывороточной болезни, крапивнице, сенной лихорадке, вазомоторном рините, при аллергических кон'юнктивитах, кератитах и некоторых других заболеваниях глаз.

Применяется внутрь и парентерально в следующих дозах: внутрь по 0,05—0,1 1—2 раза в день в порошках или таблетках (в капсулах), внутримышечно или внутривенно по 0,02—0,05 на инъекцию. Для внутримышечного введения пользуются 1—2% раствором. Для внутривенного введения растворяют 0,02—0,05 препарата в 75—100 мл изотонического раствора хлористого натрия и вводят капельным методом в течение 10 минут. Возможны побочные токсические явления: сонливость, головокружение, головная боль, сухость во рту, общая слабость, раздражительность; иногда тошнота и рвота. С отменой препарата эти явления самостоятельно

проходят. Следует отметить, что димедрол не излечивает аллергию, а дает лишь симптоматическое облегчение.

Rp. Dime droli 0,05 Sacchari 0,2 M. f. p. D. t.
d. N. 12 S. По 1 порошку 1—2 раза в
день

5. Дифенин (Dipheninum). Белый с желтоватым оттенком порошок, легко растворим в воде.

Эффективное противосудорожное средство для лечения эпилепсии, со слабым снотворным действием. Применяется per se и в сочетании с люмипалом или с бромистыми солями. Препарат также эффективен при некоторых формах хорен, при паркинсонизме, при некоторых иезпилептических судорожных состояниях, а также применяется для уменьшения явлений возбуждения при неэпилептических психозах. Назначают внутрь по 0,1 г 2—4 раза в день после еды в желатиновых капсулах или в таблетках и пилюлях, покрытых защитной оболочкой (горький вкус и раздражающее влияние на слизистую оболочку); запивают каждую дозу препарата полу-стаканом воды. В случае необходимости и при хорошей переносимости разовая доза может быть увеличена до 0,15, реже — до 0,2. Детям до 5 лет назначают по 0,03 2 раза в день, при отсутствии побочных явлений—3 раза в день; старше 5 лет — 0,05—0,1 2—3 раза в день.

Побочные токсические явления: головокружение, повышение температуры, тошнота, рвота, атаксия, кожные сыпи, зуд. При прогрессирующем развитии отмеченных явлений необходимо отменить дальнейшее применение препарата. Падение веса больного указывает на необходимость уменьшения дозировки.

Если до назначения препарата больной получал люминал или бромистые-препараты, рекомендуется переходить к дифеншгу постепенно: дозу люминала или бромидов прогрессирующие уменьшают и увеличивают дозу дифенина.

Rp. Diphenini 0,1 *
D. t. d. N. 12 in caps, gelatinosis S. По 1 капсуле 2—
3—4 раза в день после еды

6. Парааминосалициловая кислота (**ПАСК**). Белый кристаллический порошок, плохо растворимый в воде.

Для лечебных целей используется натриевая соль парааминосалициловой кислоты. Препарат задерживает рост туберкулезных палочек, но не обладает терапевтической активностью при кожной инфекции и не является жаропонижающим средством. Назначают при инфильтративных процессах в фазе распада или без явлений распада легочной ткани в тех случаях, когда нельзя применять искусственный пневмоторакс; при иодострых и хронических диссеминированных процессах в фазе затянувшейся инфильтративной вспышки с явлениями выраженной интоксикации; при хроническом фиброзно-кавернозном туберкулезе легких в инфильтративной фазе при невозможности применить хирургические способы лечения при осложнениях легочного туберкулеза с поражением гортани и кишечника.

ника; при наличии плеврально-легочного свища. Таким больным ПАСК следует вводить внутривенно.

Взрослым назначают внутрь при лечении туберкулеза 12 г в день в 4 приема, по 3 г за полчаса до еды. Истощенным больным дозу уменьшают до 8 г в день. В случае необходимости больным, хорошо переносящим препарат в обычных дозах, можно увеличить суточную дозу до 14—16 г (по 4 г на прием).

Ориентировочный курс лечения ПАСК — 3 месяца. Для промывания плевральной полости применяют 1% водный раствор в количестве 200—400 мл. Водный раствор бесцветен или слегка желтоват. Растворы следует хранить в защищенном от света месте в хорошо закрытых сосудах. Прием препарата иногда сопровождается тошнотой и рвотой. В таких случаях следует давать при каждом приеме ПАСК 0,3 жженой магнезии или $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана молока. В случаях непереносимости препарата лечение надо прекратить. Лечение должно проводиться при тщательном врачебном контроле и при систематическом исследовании мочи и крови.

Rp. PASK 3,0
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 4 раза в день за полчаса до еды

7. Теофедрин (Theophedrinum). Соответствует чехословацкому препарату аитастану — противоастматическому средству. Применяется при бронхиальной астме, артериосклерозе и при заболеваниях сосудистой системы по 1 таблетке на прием; при сильном приступе следует давать 2 таблетки, но не более 4 таблеток в сутки.

Rp. Tabuletae Theophedrim ad Scatulam orig. N. 1 DS. По 1
таблетке 1—2 раза в день

8. Фенадон (Phenadonum). Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Болеутоляющее средство, оказывающее и спазмолитическое действие. Назначают внутрь в виде порошка по 0,0025—0,005 (2,5—5 мг) или под кожу в виде 0,5% раствора по 0,5—1 мл (2,5—5 мг) при болях, связанных со спазмом гладкой мускулатуры (почечные и печеночные колики, язвенные приступы) и спазмом сосудов (стенокардия). При больших дозах (превышающих указанные) в отдельных случаях наблюдалось временно угнетение дыхания.

Rp. Phenadoni 0,003 Saecchari 0,2 M. f.
p. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку
при болях

9. Фурамон (Furamonum). Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок, гигроскопичный на воздухе, хорошо растворяется в воде. Водные растворы дают нейтральную реакцию и не изменяются при кипячении и хранении. Является заменителем пилокарпина.

Применяется при лечении различных форм глаукомы в виде 3% или 10% растворов или в виде мазей. При начальной, а также и выраженной глаукоме с давлением ниже 40 мм ртутного столба

следует начать лечение с шестикратного закапывания 3% раствора; в дальнейшем в зависимости от эффекта нужно или сокращать число закапываний, или при недостаточном действии 3% раствора переходить на 10% раствор или мазь. При выраженном глаукоме с давлением выше 40 мм следует начинать сразу с 10% раствора, вводимого в больной глаз 4—7 раз в сутки (через каждые 3 часа днем и один раз ночью). На ночь вместо капель можно закладывать за веки больного глаза перед сном мазь. При острых приступах глаукомы следует закапывать 10% раствор через каждые 15—20 минут в течение 2 часов и затем через каждые 3 часа. Растворы препарата готовят на дистиллированной воде и кипятят в течение 5 минут. Мази приготавливаются по следующей прописи:

Rp. Furamoni 0,3
Lanolini 2,0
Vasclini 8,0
MDS. Глазная мазь Rp.
Furamoni 1,0
Lanolini 2,0
Vasclini 8,0
MDS. Глазная мазь

10. Триметин (Тридион) (Trimetinum). Белый кристаллический порошок, слеживающийся при хранении, со слабым специфическим запахом, напоминающим камфору, и охлаждающим, слегка жгучим горьковатым вкусом. Растворим в воде.

Применяется как противосудорожное средство при эпилепсии. Дозировка по 0,3 три раза в день во время еды. В процессе лечения через каждые 10 дней проверяется кровь и один раз в 2—3 недели проводится исследование кровяного давления.

Наибольший эффект при лечении триметином отмечен при малых припадках* чем при больших. Из побочных явлений наблюдались головные боли, светобоязнь. Препарат по сравнению с другими терапевтическими средствами, применяемыми для лечения эпилепсии (малые припадки), является более эффективным, но*действие его нестойкое, вследствие чего наблюдаются рецидивы.

Rp. Trimetini 0,3 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку
2—3 раза в день

И. Пеллоидоэстилат (препарат ФБС — Филатов, Бибера, Ско-родинская) — препарат для тканевой терапии по Филатову. Представляет собой биогенные стимуляторы, применяемые в виде подкожных инъекций.

Действие препарата сказывается в повышении защитных реакций и в усилении процессов рассасывания и регенерации в виде подкожных инъекций.

Применяется при различных глазных заболеваниях (блефарите, помутнении стекловидного тела, пигментном ретините, конъюнктивитах, различных кератитах, при весеннем катаркте и др.), а также при лечении хронических артритов, радикулитов, миалгий, волчан-

ки, пендинской язвы, воспалительных заболеваний женской половой сферы и ряда других заболеваний.

Назначается в виде подкожных инъекций по 1 мл. Курс лечения — 30—35 инъекций. Повторный курс лечения — после месячного перерыва.

Выпускается в ампулах по 1 мл. Хранить надо в прохладном и защищенном от света месте.

Rp. Peloidoestillati 1,0 D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл под кожу 1 раз в день

12. Невуен (NeuVemim) — сухой экстракт из листьев толокнянки, освобожденный от дубильных веществ. Содержит 30% арбутипа и 12% соли кальция.

Применяется при пиелоститах и циститах в виде порошка по 0,5 три раза в день.

Rp. Neuvени 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 3 раза в день

13. Синтомицин (Syntomycinum) — синтетический антибиотик. Представляет собой почти бесцветное, со слабым желтоватым или зеленоватым оттенком кристаллическое вещество горького вкуса, трудно растворимое в воде.

Применяется при лечении дизентерии, диспепсии и брюшного тифа. Особенно высокая эффективность обнаружена при лечении дизентерии у детей.

В результате применения синтомицина при лечении острой и токсической дизентерии у детей токсикоз исчезает на 1—2-й день от начала лечения; стул в большинстве случаев оформляется на 4—5-й день от начала лечения.

При обострении хронической дизентерии, затяжных формах и при повторных поступлениях дети поддаются лечению труднее, чем при острой и токсической форме дизентерии. В этих случаях требуется увеличить курс лечения синтомицином.

Отмечена также высокая терапевтическая эффективность синтомицина при брюшном тифе у детей. Препарат укорачивает лихорадочный период, улучшает общее состояние, быстро снимает токсикоз, улучшает состояние сердечной деятельности, способствует исчезновению болей в животе, нормализует работу кишечника, улучшает сон и аппетит. Применяют синтомицин обычно per os.

Дозировка препарата при лечении детей, заболевших дизентерией и брюшным тифом, следующая. Сначала дают ударную дозу препарата двумя равными частями в два приема с промежутком в один час; затем препарат дают каждые 4—6 часов. Детям, имеющим вес до 16 кг, синтомицин дают из расчета 0,02 на 1 кг веса на каждый прием. При этом весе тела ударная доза равна суточной дозе. Детям, имеющим вес более 16 кг, назначают по 0,2—0,4 на прием 4 раза в сутки, а ударная доза при этом составляет 0,5—1,0.

Длительность лечения — от 7 до 12 дней. Для смягчения горького вкуса синтомицин дают в сахарном сиропе или в растворе глю-

козы. Синтомицин при дизентерии у детей может назначаться также и в виде свечей в двойной разовой дозе 4 раза в сутки.

Синтомицин хорошо переносится. Изредка наблюдается рвота и нательная сыпь, быстро исчезающая.

Хранить следует с предосторожностью (список Б) в стеклянной посуде оранжевого цвета

Rp. Syntomicini 0,2—0,4 D. t.

d. N. 12

S. По 1 порошку 4 раза в сутки (в течение 7—12 дней).

14. Пелоидин (**Peloidinum**). Препарат представляет собой экстракт из иловой лечебной грязи, содержащий сложный солевой комплекс (натрий, калий, кальций, магний, хлориды, сульфаты, карбонаты, фосфаты, бромиды, иодиды и пр.).

Пелоидин, приготовленный по методу проф. А. Е. Лейбензопа и М. М. Приселкова, предложен Центральным государственным научным контрольным институтом имени Тарасевича.

Пелоидин применяется внутрь, наружно и парэнтерально при различных заболеваниях (при дизентерии, колитах, энтеритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при ранах и язвах).

Дозировка: по 5 мл внутримышечно 2 раза в день. Курс лечения — 1—2 недели. Внутрь по 30—40 мл 2 раза в день; наружно в виде примочек и промываний при ранах и язвах.

Выпускается в ампулах для парэнтерального введения и в стерильных флаконах для применения внутрь и наружно. Флаконы закупориваются стерильными резиновыми пробками, залитыми смесью парафина и воска.

Хранится в прохладном затемненном месте. Для применения допускаются только прозрачные растворы. Помутневший препарат применяться не должен.

Rp. Peloidini 5,0

D. t. d. N. 10 in amp.

*

S. По 5 мл внутримышечно 2 раза в день

ГЛАВА XVIII

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

Адсорбирующие средства

Rp. Boli albae sterilisatae 100,0

DS. 1—2 столовых ложки на полстакана воды (при колитах, энтеритах и интоксикациях желудочно-кишечного тракта)

Rp. Carboleni 15,0

DS. Взболтать в полустакане воды и выпить (при острых отравлениях)

Rp. Tabulettae Carboleni 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 таблетке 3—4 раза в день (при метеоризме)

Антисептические и дезинфицирующие средства

Rp. Ac. borici 15,0

DS. 1 чайная ложка на стакан воды (полоскание)

Rp. Ac. borici pulverati 5,0

DS. Для вдвухания в ухо и при болезнях носа

Rp. Ac. borici 2,0

Vaselini ad 20,0 M.

f. ung. DS. Мазь

Rp. Ac. salicylic! 1,0

Spiritus Vini 70° 50,0

MDS. Для смазывания кожи

Rp. Ac. salicylici 2,0

01. Persicorum 100,0

MDS. Для компрессов (размягчение корочек)

Rp. Ac. salicylici 2,0 Ac.

borici 4,0 Aluminis

8,0 Zinci oxydati

Talci puri aa 40,0

MDS. Присыпка (при гипергидрозе ног)

козы. Синтомицин при дизентерии у детей может назначаться также и в виде свечей в двойной разовой дозе 4 раза в сутки.

Синтомицин хорошо переносится. Изредка наблюдается рвота и нательная сыпь, быстро исчезающая.

Хранить следует с предосторожностью (список Б) в стеклянной посуде оранжевого цвета

Rp. Syntomicini 0,2—0,4 D. t.

d. N. 12

S. По 1 порошку 4 раза в сутки (в течение 7—12 дней).

14. Пелоидин (**Peloidinum**). Препарат представляет собой экстракт из иловой лечебной грязи, содержащий сложный солевой комплекс (натрий, калий, кальций, магний, хлориды, сульфаты, карбонаты, фосфаты, бромиды, иодиды и пр.).

Пелоидин, приготовленный по методу проф. А. Е. Лейбензопа и М. М. Приселкова, предложен Центральным государственным научным контрольным институтом имени Тарасевича.

Пелоидин применяется внутрь, наружно и парэнтерально при различных заболеваниях (при дизентерии, колитах, энтеритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при ранах и язвах).

Дозировка: по 5 мл внутримышечно 2 раза в день. Курс лечения — 1—2 недели. Внутрь по 30—40 мл 2 раза в день; наружно в виде примочек и промываний при ранах и язвах.

Выпускается в ампулах для парэнтерального введения и в стерильных флаконах для применения внутрь и наружно. Флаконы закупориваются стерильными резиновыми пробками, залитыми смесью парафина и воска.

Хранится в прохладном затемненном месте. Для применения допускаются только прозрачные растворы. Помутневший препарат применяться не должен.

Rp. Peloidini 5,0

D. t. d. N. 10 in amp.

*

S. По 5 мл внутримышечно 2 раза в день

ГЛАВА XVIII

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

Адсорбирующие средства

Rp. Boli albae sterilisatae 100,0

DS. 1—2 столовых ложки на полстакана воды (при колитах, энтеритах и интоксикациях желудочно-кишечного тракта)

Rp. Carboleni 15,0

DS. Взболтать в полустакане воды и выпить (при острых отравлениях)

Rp. Tabulettae Carboleni 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 таблетке 3—4 раза в день (при метеоризме)

Антисептические и дезинфицирующие средства

Rp. Ac. borici 15,0

DS. 1 чайная ложка на стакан воды (полоскание)

Rp. Ac. borici pulverati 5,0

DS. Для вдвухания в ухо и при болезнях носа

Rp. Ac. borici 2,0

Vaselini ad 20,0 M.

f. ung. DS. Мазь

Rp. Ac. salicylic! 1,0

Spiritus Vini 70° 50,0

MDS. Для смазывания кожи

Rp. Ac. salicylici 2,0

01. Persicorum 100,0

MDS. Для компрессов (размягчение корочек)

Rp. Ac. salicylici 2,0 Ac.

borici 4,0 Aluminis

8,0 Zinci oxydati

Talci puri aa 40,0

MDS. Присыпка (при гипергидрозе ног)

- Rp. Ac. Salicylici ____
 Ac. lactici aa 1,0
 Collodii elastici 8,0
 MDS. Мозольная жидкость (смазывать 2 раза в день после горячей ванны в течение недели, затем удалить мозоль)
- Rp. Ac. Salicylici 1,0 Zinci oxydati
 Amvli tritici aa 12,5 Vaselini
 ad 50,0 M. f. pasta DS. Паста (паста Лассара)
- Rp. Airoli 2,0 Vaselini 18,0 M.
 f. ung. DS. Мазь (глазная)
- Rp. Albichtholi 5,0 Vaselini ad 50,0 M. f. ung. DS.
 Мазь (при экземе, дерматитах)
- Rp. Albichtholi 10,0 Glycerini 50,0 MDS. Для влагалищных тампонов
- Rp. Albichtholi 0,2
 Extr. Belladonnae 0,02 But.
 Cacao 2,0 M. f. suppos. D. t. d. N. 10
 S. По 1 свече 1—2 раза в день в прямую кишку (при геморрое, оофорите, сальпингите)
- Rp. Antiformini 10,0
 DS. Для дезинфекции и разрушения зубной пульпы
- Rp. Balsami Peruviani 20,0
 Spiritus Vini ad 100,0
 MDS. "Для втирания в кожу при паразитарных заболеваниях
- Rp. Beracis 1,5
 Balsami Peruviani 0,5
 Lanolini _
 Vaselini aa 15,0 M. f. ung.
 DS. Мазь для смазывания сосков при трещинах
- Rp. Beracis 5,0
 Glyctrini ad 30,0
 MDS. Для смазывания слизистой рта (при афтах)

- Rp. Natrii bcrici
 Nnrii bic;rbonici
 Natrii chlorati aa 10,0
 M. f. pulv.
 DS. Чайная ложка на стакан воды (полоскание)
- Rp. Brilliantgrun 1,0
 Spiritus Vini 70° 50,0
 MDS. Наружное (смазывать кисточкой пораженные места при пиодермии) Rp. Sol. Brilliantgrun 1% 30,0
 DS. Наружное (при язвенном блефарите)
- R.p. Sol. Dakini 200,0
 DS. Для промывания ран
- Rp. Sol. Chlcrimini 0,2% 200,0
 DS. Для промываний, спринцеваний Rp.
- Sol. Collargoli 2% 10,0
 DS. Глазные капли (при конъюнктивите, бленоррее глаз) Rp.
 Sol. Collargoli 1% 100,0
 DS. На 2 клизмы
- Rp. Dermatoli 5,0
 DS. Присыпка
- Rp. Ung. Dermatoli 10% 30,0
 DS. Мазь ,
- Rp. Fermalini 5,0
 Spiritus Vini 70° 200,0
 MDS. Для обтирания ног (при потении)
- Rp. Formalini 30,0
 DS. 1 чайная ложка на 2 стакана воды (обмывание кожи)
- Rp. Sol. Hydrargyri bichlorati (1 : 2 000) 200,0 DS.
 Для промывания
- Rp. Calomelanos
 Talci puri aa 5,0
 M. f. pulv.
 Tfe. Присыпка (при сифилитических язвах)
- Rp. Ung. Hydrargyri cinerei 3,0
 D. t. d. N. 12 ad chartam ceratam S. Втирать в кожу ежедневно по 1 порции (при сифилисе)
- Rp. Ung. Hydrargyri praecipitati albi 15,0
 DS. Мазь (при псориазе волосистой части головы)
- Rp. Sol. Hydrargyri oxysuapati (1 : 3 000) 100,0 DS.
 Глазная примочка

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

- Rp. Hydrargyri praecipitati albi Bismuti subnitrici aa 1,0 Vaselini albi Lanolini anhydrici aa 5,0 M. f. ung. DS. Мазь (при угрях, педикулезе лобка)
- Rp. Ung. Hydrargyri oxydati flavi 5,0 DS. Глазная мазь
- Rp. Hydrargyri oxydati flavi 6,0 Besorcini 2,0 Bismuti subnitrici 10,0 Vaselini ad 100,0 M. f. ung. DS. Мазь при пиодермиях
- Bp. Hydrargyri oxydati flavi 0,1 Atropini sulfurici 0,05 Vaselini 10,0 M. f. ung. DS. Глазная мазь (при ирите)
- Bp. Hydrogenii peroxysoluti 50,0 DS. 1 столовая ложка на полстакана воды (полоскание)
- Bp. Perhydroli 10,0 Aq. destill. 40,0 MDS. 1 чайная ложка на стакан воды (полоскание)
- Bp. Ung. Ichthyoli 10% 30,0 DS. Мазь (при экземе, ожогах)
- Bp. Ichthyoli 0,2 But. Cacao 2,0 M. f. globulus vaginalis D. t. d. N. 10 S. Влагалищные шарики
- Bp. Ichthyoli 10,0 Glycerini 40,0 MDS. Для влагалищных тампонов
- Bp. Ichthyoli 0,2 Kalii j. dati 0,1 Extr. Belladonnae 0,02 But. Cacao 2,0 M. f. supp. D. t. d. N. 6 S. Утром и вечером по 1 свече в прямую кишку (при простатите)
- Rp. T-rae Jodi 10,0 DS. Для смазывания

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК
0

**П

- Bp. Jodi puri 5,0 Kalii jodati 10,0 Aq. destill. 100,0 MDS. Люголевский раствор
- Bp. Jodi puri 0,15 Ung. Kalii jodati 15,0 Extr. Belladonnae 1,0 M. f. ung. DS. Мазь (при невралгии, эпидидимите)
- Rp. Tannini T-rae Jodi aa 5,0 Glycerini 20,0 MDS. Для смазывания (при ингивите)
- Rp. Jodi puri Kalii jodati aa 0,5 Glycerini 20,0 Aq. destill. 100,0 MDS. По половине чайной ложки для вливания в нос (при рините)
- Rp. Jodoformii 5,0 DS. Присыпка
- Rp. Jodoformii 1,0 Vaselini ad 10,0 M. f. ung. DS. Мазь (при адените)
- Rp. Kalii chlorici 15,0 DS. 1 чайная ложка на стакан воды (полоскание)
- Rp. Sol. Kalii hypermanganici 0,02% 500,0 DS. Для спринцевания и промывания пузыря (при уретрите, цистите)
- Rp. Sol. Kalii hypermanganici 10% 50,0 DS. Смазывать при ожогах
- Rp. Sol. Kalii hypermanganici 0,4% 100,0 DS. По 1 столовой ложке (повторно) при отравлении фосфором, морфином, цианистым калием
- Rp. Kreosoti 10,0 Camphorae 0,5 MDS. 5—6 капель на вате в кариозную полость
- Rp. Lysoformii 50,0 DS. 1-2 чайных ложки на 1 л воды для спринцеваний
- Rp. Sol. Lysoli 2% 200,0 DS. Для дезинфекции

*

- Rp. Lysoli 50,0
DS. 1—2 чайных ложки на 1 л воды (для спринцеваний)
- Rp. Amyli tritici
Zinci oxydati aa 10,0
Naphtalani 20,0
M. f. pasta
DS. Паста (при хронических экземах)
- Rp. Sulfuris praecipitati Picis Liquidae
aa 15,0 Saponis viridis 30,0
Naphtalani 40,0 M. f. ung. DS.
Мазь (против чесотки)
- Rp. Betanaphtoli 2,0
Sulfuris praecipitati 8,0
Saponis viridis 10,0
Axungiae porci 30,0
M. f. ung.
DS. Антипаразитарная мазь
- Rp. Picis liquidae
Spiritus Vini aa 30,0
MDS. Наружное (при хронической экземе)
- Rp. Ung. Wilkinsoni 50,0
DS. Мазь (против чесотки)
- Rp. Picis liquidae 3,0
T-rae Jodi 10% 1,0
Ol. Ricini 100,0
MDS. Мазь Вишневского *
- Rp. Sol. Protargoli 2% 10,0 DS.
Глазные капли
- Rp. Sol. Protargoli 1% 10,0
DS. Капли для носа (по 2—3 капли 2 раза в день)
- Rp. Sol. Protargoli 1% 100,0
DS. Для промывания носовой полости при озене
- Rp. Protargoli 1,0 Vasolini
puri 9,0 M. f. ung.
DS. Глазная мазь
- Rp. Sol. Resorcini 1—2% 100,0 DS.
Для примочек

- Rp. Resorcini 0,1 Spiritus Vini 5,0 Aq.
destill. 10,0 MDS. По 1—2 капли
в ут
- Rp. Resorcini
Sulfuris praecipitati
Ichthvoli aa 1,0
Vasolini ad 20,0
M. f. ung.
DS. Мазь (при себоррее)
- Rp. Resorcini 1,0 Naphtalani Lanolini
Vasolini aa 10,0 M. f. ung. DS. Мазь
(при экземе, себоррее)
- Rp. Resorcini
Ac. Silicylici aa 2,0
Spiritus Vini ad 100,0
MDS. Наружное (для обтираний при сикозе, при угрях)
- Rp. Resorcini 5,0 Ol. Ricini 3,0 Spiritus-Vini 70° 200,0
MDS. Для обмывания кожи головы при перхоти
- Rp. Resorcini
Pepsini
Ac. hydrochlorici diluti aa 4,0 Aq.
Menthae ad 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день во время еды
- Rp. Sol. Rivanoli (1:1000—1:500) 200,0 DS.
Для промывания ран
- Rp. Sol. Rivanoli 1% 30,0
DS. Для смазывания десен (при стоматите)
- Rp. Thymoli 0,1
Glycerini 10,0 Aq. destill. ad
100,0 MDS. Смазывание (при зуде)
- Rp. Sol. Tricresoli 0,5% 100,0
DS. Для дезинфекции
- Rp. Xeroformii 5,0 DS.
Присыпка
- Rp. Ung. Xeroformii 5% 15,0
DS. Мазь (при эрозиях, экскориациях; язвах)

Rp. Xeroformii 1,0 Zirici oxydati 5,0
Lnnolini Vaselini aa 10,0 M. f. ung.
DS. Мазь (при эрозии, язве)

Болеутоляющие, обезболивающие и противоневралгические средства

Rp. Analgini 0,5 D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 2—3 раза в день (при радикулите, ревматизме)

Rp. Sol. Analgini 50% 10,0
S. По 20 капель 2—3 раза в день или внутримышечно по 1 мл 1—2 раза в день

Rp. Antipyrini 0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Antipyrini 0,5
Coffeini natrio-benzoici 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp. Antipyrini 0,5
Papaverini hydrochlorici 0,03 M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 2 раза в день (противоспазматическое, болеутоляющее)

Rp. Antipyrini 0,3
Omnoponi 0,02
Extr. Belladonnae 0,01 *
But. Cacao 1,5 M. f. supp. D. t. d. N. 6
S. По 1 свече в прямую кишку (для обезболивания при родах)

Rp. Aspirini 0,25—0,5—1,0 D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Aspirini 0,25
Coffeini natrio-benzoici 0,1
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp. Aspirini Phenacetini
Pyramidoni aa 0,2

Codeini 0,01
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день (при гриппе, невралгии)

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici 1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 ампуле под кожу

Rp. Morphini hydrochlorici 0,015
Sacchari 0,2
M. f. pxilv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Rp. Morphini hydrochlorici 0,1
Aq. Amygdalarum amararum 10,0 MDS. По 15—20 капель 2 раза в день

Rp. Morphini hydrochlorici Extr. Belladonnae aa 0,01
But. Cacao 1,5 M. f. supp. D. t. d. N. 6 S. По 1 свече на ночь в прямую кишку

Rp. Sol. Omnoponi 2% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 ампуле под кожу

Rp. Sol. Omnoponi 2% 10,0
DS. По 10—15 капель 2—3 раза в день

Rp. Sol. Omnoponi 1% 10,0
DS. Детям 1 капля на год жизни. (До 1 года не давать)

Rp. Omnoponi 0,015
Extr. Belladonnae 0,02
But. Cacao 2,0
M. f. supp. D. t. d. N. 6
S. По 1 свече на ночь в прямую кишку

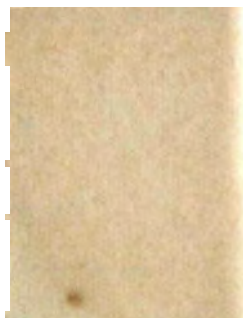
Rp. Phenacetini 0,3—0,5
Coffeini natrio-benzoici 0,1—0,2 M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день (при головной боли)

Rp. Phenacetini
Pyramidoni aa 0,2
Coffeini natrio-benzoici 0,1
Luminali 0,05
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день ■

- Rp. Phenacetini 0,3 Aspirini 0,5
Coffeini natrio-benzoici 0,2 M. f. pulv.
I) t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Pyramidoni 0,3—0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2—3 раза в день
- Rp. Pyramidoni 0,3
Coffeini natrio-benzoici 0,1 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2—3 раза в день (при боли, гриппе)
- Rp. Pyramidoni 0,3 Luminali 0,05 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2—3 раза в день
- Rp. Pyramidoni 0,3 Veronali 0,15 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2—3 раза в день
- Rp. Pyramidoni 0,3 Phenacetini 0,2 Coffeini natrio-benzoici 0,1 M. f. pulv. D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 2—3 раза в день
- Rp. Tecodini 0,01 Sacchari 0,2 M. f. p. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 1—2 раза в день
- Rp. Salipyrini 0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2—3 раза в день
- Rp. Salipyrini 0,5
Coffeini natrio-benzoici 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Возбуждающие средства

- Rp. 01. Camphorati 20% 10,0 Sterilisetur!
DS. По 1—2 мл под кожу
- Rp. Sol. Coffeini natrio-benzoici 20%
Sterilisetur! DS. По 1—2 мл под кожу



(при головной

- Rp. Coffeini natrio-benzoici 0,2 D. t. d. N. 6 in tab. S. По 1—2—3 таблетки в день
- Rp. Extr. Colac fluidi 15,0
DS. По 20—30 капель 2—3 раза в день
- Rp. Sol. Corasoli 10% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу или в вену
- Rp. Cordiamini 1,0
D. t.-d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл под кожу или в вену
- Rp. Cordiamini 15,0
DS. По 30—40 капель 3—4 раза в день
- Rp. Cytitoni 1,0
D. t. d. N. 6 in amp. S. По 0,5—1 мл в вену
- Rp. Sol. Ephedrini hydrochlorici 5% 1,0 D. t., d. N. 6 in amp. S. По 0,5—1 мл под кожу (при коллапсе, шоке)
- Rp. Sol. Lobelini hydrochlorici 1% 1,0 D. t. d. N. 6 in a*mp. S. По 0,5—1 мл под кожу
- Rp. Sol. Strychnini nitrici 0,1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день
- Rp. T-rae Strychni 5,0 Extr. Colae fluidi 15,0 MDS. По 15—10—25 капель 2 раза в день
- Rp. T-rae Schizandrae
ch mnsis 10,0 DS. По 3J—40 капель 2—3 раза в день
- Rp. T-rae Ginseng 20,0
DS. По 20—30 капель 2—3 раза в день

* Вяжущие средства

*

- Rp. Sol. Aluminis 2% 200,0 DS.
Полоскание
- Rp. Aluminis usti 5,0 DS.
Присыпка
- Rp. Aluminis usti
Zinci sulfurici aa 30,0
MDS. 1 чайная ложка на 1 л воды (для спринцеваний)

- Rp. Aluminis 5,0 Ac borici 10 0 Glycerini 100,0 MDS.
Для тампонов (при вульвовагините)
- Rp. Liq. Burovi 50,0 [^]L[^] [^]
DS. 2 столовых ложки на стакан воды для примочек (при воспалительных процессах кожи)
- Rp. Aluminis 5,0 Ac borici 4,0 Aq. destill 200,0
MDS. Наружное. При острой экземе и воспалительных процессах кожи
- Rp. Aq. Plumbi 200,0
DS. Для примочек и обмываний
- Rp. Sol. Argenti nitrici 0,2 : 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день за четверть часа до еды (при язве желудка)
- Rp. Sol. Argenti nitrici 1% 10,0
DS. Для смазывания слизистой оболочки века
- Rp. Argenti nitrici 0,3 Vaseline ad 30,0 M. f. ung. DS. Мазь
- Rp. Argenti nitrici 0,3 Balsami Peruviani 3,0 Vaseline albi 30,0 M. f. ung. DS. Мазь Микулича
- Rj). Bismuti subnitrici 0,3—0,5 .
D. t. d. N. 12 »
S. По 1 порошку 3—4 раза в день
- Rp. Bismuti subnitrici 0,5 Saloli 0,3 M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3—4 раза в день
- Rp. Bismuti subnitrici 5,0 DS.
Присыпка
- Rp. Bismuti subnitrici Tannalini aa 0,25 M. f. pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день (ребенку 8—10 лет)
- Rp. Dermatoli 3,0 DS.
Присыпка



- Rp. Calcii carbonici 30,0 01. Menthae gtt. V M. f. pulv. DS.
Зубной порошок
- Rp. Sol. Cupri sulfurici 0,25% 10,0
DS. Глазные капли. По 2—3 капли в глаз (при конъюнктивите)
- Rp. Liq. Burovi 100,0
DS. По 1—2—3 столовых ложки на стакан кипяченой воды (примочка)
- Rp. Plumbi acetici 10,0 Tannini 5,0 Lanolini anhydrici 40,0 Vaseline 45,0 • M. f. ung? DS. Мазь (при пролежнях)
- Rp. Plumbi acetici 0,25 Aq. destill. 50,0 MDS.
Примочка
- Rp. Empl. Plumbi simplicis Vaseline albi aa 15,0 M. f. ung. DS. Мазь (при дерматитах) f
- Rp. Aq. Plumbi Aq. Laurocerasi Aq. Menthae aa 20,0 MDS. Для компрессов (при зуде)
- Rp. Plumbi acetici 10,0 Aq. destill. 100,0 MDS. По 2 чайных ложки на 1 л воды (для спринцеваний)
- Rp. Decosti Quercus aluminati 200,0 DS.
Полоскание (при стоматите)
- Rp. In#. folii Salviae ex 15,0—200,0 DS.
Полоскание (при стоматите)
- Rp. Sanalini 0,3—1,0 D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3—4 раза в день (вместо танналь-бина)
- Rp. Tannalini 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день (при энтерите)

- Rp. Tannalbini
Benzonaphtcli aa 0,3 M. f.
pulv. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3—4 раза в день (при остром эрите,
колите)
- йр. Tannini 2,0
Glycerini ad 20 0
MDS. Для смазывания десен
- Rp. Sol. Tannini 5% 100.0
MDS. Для смазывания при ожогах кожи
- Rp. Tannini 5,0 T-rae Jodil.O Aq.
destill. ad 20 0 MDS. Для
смазывания зева
- Rp. Tannini
Liq. Plumbi subacetici aa 2,0 Axungiae
Porci ad 20,0 M. f. ung. DS. Для
смазываний пролежней
- Rp. Bistalbins 0,3—1,0 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3—4
раза в день (вместо таннальбина)
- Rp. Tannini 0,6
Gummi arabici 1,4
T-rae Opii gtt. III
Aq. destill. 60.0
MDS. На 1 клизму (при остром колите)
- Rp. Decocti folii Uvae ursi 10,0—180,0 Sir. simplicis ad 100,0
MDS. По 1 столовой ложке через 3—4
часа (при
цистите, дизентерии)
- Rp. Zinci oxydati
Talcii puri aa 15,0 M.
f. pulv. DS.
Присыпка
- Rp. Ung. Zinci 15,0
DS. Мазь
- Rp. Zinci oxydati
Amyli tritici aa 15,0
Lanolini 10,0 MDS.
Мазь
- Rp. Zinci oxydati
Boli albae aa 15,0 M.
f. pulv. DS.
Присыпка

- Rp. Pol. Zinci sulfurici 0,25% 10,0 DS.
Глазные капли
- Rp. Zinci sulfurici 0 03
Sol. Ac. borici 2% 10,0
MDS. Глазные капли
- Rp. Zinci sulfurici
Plumbi acetici aa 0,25
Aq. destill. 200.0
MDS. Для спринцеваний
- Rp. T-rae* Hyperici 15,0
DS. Для смазывания десен
- Rp. T-rae Tormentillae 15,0 Glycerini
5,0 MDS. Для смазывания десен
- Жаропонижающие средства
- Rp. Antipyrini 0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1
порошку 2—3 раза в день
- Rp. Aspirini 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 3—4 раза в день
- Rp. Chinini hydrochlorici 0,3 D. t. d. N. 12
in tab. S. По 1 таблетке 2—3 раза в
день
- Rp. Natrii salicylici 0,5
Coffeini natrio-benzoici 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3—4 раза в день
- Rp. Phenacetini 0,3—0,5 D. t. d. N. 6 S. По
1 порошку 2—3 раза в день
- Rp. Pyramidoni 0,3—0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1
порошку 2—3' раза в день
- Rp. Salipyrini 0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1
порошку 2—3 раза в день
- Rp. Aspirini
Phenacetini aa 0,3 Coffeini natrio-
benzoici 0,1 M. f. pulv. D. t. d. N. 10 S.
По 1 порошку 3 раза в день

Желудочно-кишечные средства Средства>
способствующие пищеварению в желудке

Г о р е ч и

Rp. T-rae Absinthii 15,0
DS. По 15—20 капель 2—3 раза в день перед едой Rp.
T-rae amarae 15,0
DS. По 15—20 капель 2—3 раза в день перед едой Rp.
T-rae Chinae compositae
T-rae Gentianae aa 10,0
MDS. По 20—30 капель 3 раза в день перед едой

К и с л о т ы и ф е р м е н т ы

Rp. Ac. hydrochlorici diluti 15,0
DS. По 10—15 капель в воде 2—3 раза в день во время еды
Rp. Ac. hydrochlorici diluti 3,0
Pepsini 2,0
Aq. destill. 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 2 раза в день во время еды
Rp. Ac. hydrochlorici diluti 10,0
Pepsini 5,0
Aq. destill. 100,0
MDS. По 1 чайной ложке на полстакана воды во время еды
Rp. Pepsini
Ac. hydrochlorici diluti aa 1,0
Aq. destill. 90,0
Sir. simplicis 10,0 • MDS. По 1 чайной—1 десертной ложке 2
раза в день во время еды Rp. Pepsini 0,3
Ac. hydrochlorici diluti gtt. VIII »
Aq. destill.
Sir. simplicis aa 30,0
MDS. По 1 чайной ложке 3 раза в день (при диспепсии детям
грудного возраста) Rp. Succ. gastrici naturalis 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день во время еды

П р о т и в о к и с л о т н ы е с р е д с т в а

Rp. Natrii bicarbonici 0,5—1,0
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3—4 раза в день после еды Rp.
Natrii bicarbonici
Magnesiae ustae aa 15,0
M. f. pulv.
DS. По половине чайной ложки 2—3 раза в день (при
повышенной кислотности)

и

Rp. Natrii bicarbonici Magnesiae ustae
Magnesiae carbonicae aa 0,3 M. i.
pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 2—3 раза в день после еды (при кислотом
катаре и язве желудка)
Rp. Magnesiae ustae 10,0 Aq.
destill. 150,0
MDS. Перед употреблением взбалтывать. По 1
столовой ложке через 5—10 минут (при
отравлении кислотами)

С л а б и т е л ь н ы е с р е д с т в а

Rp. Calomelanos 0,2 , Sacchari
lactis 0,3 M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку через 2 часа до действия (не больше 3
порошков)
Rp. Calomelanos 0,02 ■ Sacchari
lactis 0,3 M. f. pulv. D. t. d.
N. 6
S. По 1 порошку через 1 час до действия (для детей от
2 до 5 лет)
Rp. Extr. Frangulae fluidi 30,0
DS. По у₂—1 чайной ложке на ночь
Rp. Franguleni 30,0
DS. 1—2—3 чайных ложки на ночь
Rp. Magnesii sulfurici 15,0—30,0
DS. Hal прием, растворить в стакане теплой воды
Rp. Natrii sulfurici 15,0—30,0
DS. На 1 прием, растворить в стакане теплой воды
Rp. 01. Ricini 30,0 DS.
На 1 прием
Rp. 01. Ricini 2,0
D*. t. d. N. 12 in caps. gelatinosis S.
Принять в течение 30 минут
Rp. Emuls. 01. Ricini 100,0 Sir.
corticis Aurantii 20 0
MDS. По 1 десертной ложке через каждый час до
действия (ребенку 3—5 лет)
Rp. Paraffini liquid! 1R0,0 01. Menthae gtt. II MDS. По 1
столовой ложке 2—3 раза в день

- Rp. Purgeni 0,1
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1—2 таблетки на ночь
- Rp. Purgenoli 75,0
2 чайных ложки
- DS. По I на
- Rp. Pulv. Liquiritiae compositi 30,0 DS. 1
чайная ложка на стакан воды
- Rp. Pulv. BoШпи 30,0
DS. 1 чайная — 1 десертная ложка на стакан вол
- Rp. Pulv. Magnesiaе cum Rheo 15,0
DS. По $\frac{7}{8}$ чайной ложки на прием (при запора у детей)
- Rp. Decocti fructus Rhamni catharticae 20,0:200,0
DS. Принимать по полстакана на ночь
- Rp. Pulv. Rhei 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 2 раза в день
- Rp. Sirupi Rhei 30,0
DS. По 1 чайной ложке 2 раза в день (детям)
- Rp. Salis Carolini factitii 30,0
DS. 1—2 чайных ложки на стакан теплой воды (пнмать утром натощак)
- Rp. Inf. Sennae compositi 30,0 •
DS. На 1 прием
- Rp. Inf. Sennae salini 50,0
DS. На 1 столовой ложке через час до действия
- Rp. Sulfuris depurati
Magnesiaе ustae
Pulveris Rhei
Eleosacchari Foeniculi aa 5,0 M. f. pulv.
DS. По $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке на прием 1—2 раза в де (слабительное)

Антисептики для кишечника

- Rp. Benzonaftoli 0,2 D. 0,5 t. d. N. 6
S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Calomelanos 0,05
Sacchari 0,2

- M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день
- Rp. Magnesii peroxydati 0,5 D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день перед едой или после еды
- Rp. Saloli 0,3—0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

Противопоносные средства

- Rp. Bismuti subnitrici 0,5 Saloli 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3—4 раза в день
- Rp. Bismuti subnitrici 0,5 Extr. Opii 0,015
M. f. pulv. D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Boli albae 100,0
DS. По 1—2 столовых ложки натощак, взбалтывать с водой
- Rp. Boli albae 5,0
Mucilaginis Salep 100,0
MDS. По 1 чайной ложке через 2—3 часа (при детских поносах)
- Rp. Calcii carbonici
Bismuti subnitrici aa 0,3
Tannalbin 0 5
M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Opii puri 0,03 Saloli
Bismuti subnitrici aa 0,3 M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. *по 1 порошку 3—4 раза в день
- Rp. Guttae Inozemzovi 15,0
DS. По 15—20—30 капель 2—3 раза в день
- Rp. Sanalbin 0,5 Saloli 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3—4 раза в день
- Rp. T-rae Opii simplicis 5,0
DS. По 5—10 капель 2—3 раза в день

- Rp. T-rae Opii simplicis 5,0 T-rae Nucis vomicae 1,0 T-rae Valerianae aetherae 10,0 01. Menthae gtt. III
MDS. По 15—30 капель 2 раза в день (при остром энтерите)
- Rp. T-rae Opii simplicis 0,5
Mucilaginis Salep 100,0
MDS. Для клизмы

Желчегонные средства

- Rp. Atophani 0,5
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды, запивать стаканом боржома
- Rp. Calomelanos 0,06
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку через 2 часа (желчегонное)
- Rp. Cbologoni (Decholini) 0,25 D. t. d. N. 12 in tab. S. По 1 таблетке 3 раза в день
- Rp. Cholosasi 1 флакон
DS. По 1 чайной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды (при холециститах)
- Rp. Decocti florum Stoechados citrinae 10,0:2 000 DS.
По $\frac{1}{4}$ стакана 3—4 раза в день до еды
- Rp. Extr. Stoechados citrinae fluidi 50,0 *
DS. По 30—40 капель на рюмку воды 3—4 раза в день перед едой
- Rp. Sol. Magnesii sulfurici 25% 50,0
DS. В подогретом виде ввести через дуоденальный зонд (как желчегонное) *
- Rp. Decocti rad. Taraxaci 8,0—200,0
DS. По $\frac{1}{i}$ стакана 3—4 раза в день перед едой

Антисептики желчных путей

- Rp. Mentholi 1,0
01. Persicorum 20,0
Aq. destill. 130,0
MDS. По 1 столовой ложке 3—4—5 раз в день

- Rp. Urotropini 0,3—0,5 D. t. d. N. 12 S.
По 1 порошку 3—4 раза в день,
- Rp. Urotropini 0,5
Natrii salicylici 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 .,.-...
S. По 1 порошку 3 раза в день ,
- Rp. Sol. Urotropini sterilisatae 40% 5,0 DS.
По 5 мл в вену

Кровоостанавливающие средства

- Rp. Sol. Adrenalini hydrochlorici (1:1000) 3,0 DS. Для смазывания (местное действие)
- Rp. Sol. Calcii chlorati 5% 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день на молоке
- Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 10,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 10 мл в вену
- Rp. Sol. Calcii gluconici 10% 30,0
Sterilisetur! i
DS. По 5—10 мл в вену
- Rp. Ergotini 10% 1,0 : i-i
D. t. d. N. 6 in amp. S.
По 1 мл под кожу
- Rp. Extr. Millefolii fluidi 30,0
DS. По 30—40 капель 3—4 раза в день
- Rp. Sol. Gelatinae albae 10% 100,0
DS. По 1 столовой ложке через 1—2 часа (при желудочных кровотечениях)
- Rp. Sol. Gelatinae albae sterilisatae 10% 40,0 D. ad ampulam originalem
S. Для подкожных впрыскиваний 20—40 мл (детям 5—10 мл)
- Rp. Sol. Gelatinae albae 10% 100,0 DS. На 2 клизмы
- Rp. Liquoris Ferri sesquichlorati 50,0
DS. Для тампонов (кровоостанавливающее)
- Rp. Stypticini 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 2—3 раза в день .

- Rp. Sol. Stypticini sterilisatae 5% 5,0
DS. По 1 мл под кожу
- Rp. Vicasoli 0,015
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке в день в водном растворе в течение 3—4 дней подряд
- Rp. Extr. Stigmatis Maydis fl. 20,0
DS. По 20 — 30 капель перед едой 3 — 4 раза в день

Маточные средства

- Rp. Extr. Bursae pastoris fluidi 20,0
DS. По 30—40 капель 3—4 раза в день
- Rp. Chinini hydrochlorici 0,15
D. t. d. N. 6 in oblatiis
S. По 1 облатке на прием (при слабости родовых потуг) Rp. Cornusoli 2,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1—2 мл под кожу 1—2 раза в день
- Rp. Extr. Hydrastidis fluidi 5,0
DS. По 20—30 капель 3—4 раза в день
- Rp. Extr. Hydrastidis fluidi Extr. Viburni fluidi aa 7,5 MDS. По 20—30 капель 2—3—4 раза в день
- Rp. Sol. Hydrastininini hydrochlorici 5% 20,0 .
Sterilisetur!
DS. По 1 мл 2 раза в день под кожу или по 20—30 капель внутрь
- Rp. Pituitrini 1,0 «
D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу
- Rp. Extr. Polygoni hydropiperis fluidi 20,0 DS.
По 30—40 капель 3—4 раза в день
- Rp. Extr. Secalis cornuti fluidi 15,0 DS. По 15—20 капель 3 раза в день
- Rp. Ergotini 10% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу
- Rp. Secaleni 15,0
DS. По 15—20 капель 2—3 раза в день
- Rp. Pulv. Secalis cornuti 0,6
D. t. d. N. 6 in charta cerata S. По 1 порошку 3 раза в день

- Rp. Stypticini 0,05
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
- Rp. Sol. Stypticini sterilisatae 5% 10,0
DS. По 1 мл под кожу 1—2—3 раза в день
- Rp. Extr. Hydrastidis fluidi Extr. Viburni fluidi Extr. Gossypii fluidi aa 5,0 MDS. По 20—30 капель 3 раза в день
- Местноанестезирующие средства
- Rp. Aethylchlorati
D. t. d. N. 3 in amp.
S. Для местной анестезия
- Rp. Anaesthrisini 0,3 D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2 раза в день (при гастралгии, рвоте)
- Rp. Anaepthesini 0,2 Xoroformii 0,1 But. Sacao 2,0 M. f. supp. D. t. d. N. 6 S. По 1 свече 2 раза в день (при трещинах)
- Rp. Menthom 0,5 Anaesthesini 1,0 Vaselini ad 10,0 M. f. ung. DS. Мавь для носа
- Rp. Sol. Cocaini hydrochlorici 2% 5 0
Sol. Adrenalinini hydrochlorici (1 : 1 000) gtt. III MDS. Для анестезии слизистой с" >оочки глаз
- Rp. Zinci sulfuric] 0 03
Cccaini hyilrochlorici 0,1
Sol. Adrenalinini hydrochlorici (1 : 1 000) 0,3
Sol. Ac. borici 2% 10,0.
MDS. Глазные капли
- Rp. Cocaini hydrochlorici 0,01
Xoroformii 0,15 But. Sacao 2,0 M. f. supp. D. t. d. N. 6 „ S. По 1 свечевпрямуюкишку(пригеморрое,трещинах)
- Rp. Sol. Dicaini 0,25—0,5—1% 10.0
DS. Для поверхностной анестезии в офтальмологии
- Rp. Sol. Dicaini 1—2—3% 10,0
DS. Для поверхностной анестезии в ото-рино-ларии-гологии

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

- Rp. Sol. Dionini 5% 10,0
DS. Глазные капли (при кератите и воспалениях радужной оболочки)
- Rp. Thymoli 5,0
Spiritus Vini 95°
Aetheris sulfurici aa 4,0
MDS. Жидкость для обезболивания дентина
- Rp. Sol. Novocaini 2% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. Для проводниковой анестезии
- Rp. Sol. Novocaini 0,25% 150,0 Sterilisetur! DS.
Для инфильтрационной анестезии
- Rp. Novocaini 2,5
Natrii chlorati 6,0 Kalii chlorati 0,075 Calcii chlorati 0,125 Aq. destill. 1 000,0 Sterilisetur!
MDS. Для местной анестезии по методу ползучего инфильтрата (по Вишневскому)
- Rp. Novocaini 0,03
Extr. Opii 0,01
Extr. Belladonnae 0,02
Dermatoli 0,5
But. Cacao 1,5 M. f. supp. D. t. d. N. 6
"S. По 1 свече 2 раза в день в прямую кишку (при геморрое, трещинах в слизистой прямой кишки)
- Rp. Novocaini 0,1 %
Spiritus Vini Glycerini aa 7,5 MDS. Ушные капли

Мочегонные средства

- Rp. Inf. rad. Angelicae 15,0 : 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
- Rp. Inf. gemmarum Betulae 20,0 : 200,0
DS. По 2 столовых ложки 3—4 раза в день
- Rp. Diuretini 0,5
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день
- Rp. Inf. baccarum juniperi 15,0 : 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

РЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

- Rp. Inf. baccarum juniperi 10,0 : 200,0 Liq. Kalii acetici 10,0 MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
- Rp. Liq. Kalii acetici 10,0 Aq. Menthae 100,0 Sir. simplicis 10,0 MDS. По 1 столовой ложке через 2 часа
- Rp. Sol. Mercusali 10% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1-мл через 1—2 дня в мышцу
- Rp. Inf. seminis Petroselini 10,0 : 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
- Rp. Decocti herbae Equiseti arv. 15,0:200,0 DS.
По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
- Rp. Theophyllini 0,1
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день
- Rp. Euphyllini 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulv D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

Антисептики мочевых путей

- Rp. Saloli 0,3—0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Urotropini 0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Decocti folii Uvae ursi 15,0 : 200,0
DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Наркотические средства

«

- Rp. Aethylii chlorati 25,0 D. t. d. N. 3 in amp. S. Для общего кратковременного наркоза
- Rp. Aetheris pro narcosi 100,0 D. t. d. N. 3 S.
Для ингаляционного наркоза
- Rp. Chloroformii pro narccsi 50,0 D. t. d. N. 4 S. Для ингаляционного наркоза

- Rp. Hexenali 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для основного наркоза (базисного)
Rp. Sol. Magnesium sulfurici 20% 20,0 D.
Sterilisetur!
S. Для базисного наркоза (под кожу или в мышцу) по 10—15 мл

Отхаркивающие средства

- Rp. Liq. Ammonii anisati 2,0 Natrii benzoici 0,6 Sir. Althaeae 30,0
MDS. По 1 чайной ложке через 2—3 часа (детям 2—5 лет при остром бронхите)
Rp. Decocti rad. Althaeae 5,0—100,0 Sir. Althaeae 20,0 Liq. Ammonii anisati 2,0
MDS. По 1 десертной ложке через 3 часа (детям 5—8 лет)
Rp. Apomorphini hydrochlorici Dionini aa 0,03 Ac. hydrochlorici diluti 0,5 Aq. destill. 180,0
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день (отхаркивающее и успокаивающее кашель)
Rp. Inf. rad. Ipecacuanhae 0,5 : 180,0 Ammonii chlorati 4,0 Codeini phosphorici 0,2 Sir. simplicis 20,0 MDS. По 1 столовой ложке через 3 часа
Rp. Inf. rad. Ipecacuanhae 0,1—100,0 Liq. Ammonii anisati 1,0 Sir. Althaeae 20,0
MDS. По 1 чайной ложке 5—6 раз в день (ребенку 6—8 месяцев)
Rp. T-rae Opii benzoicae Elix. proctoralis aa 15,0
Codeini phosphorici 0,3 MDS. По 20—30 капель 3 раза в день
Rp. Pertussini 100,0
DS. По 1 чайной ложке 2—3—4 раза в день
Rp. Pulv. Doveri 0,25 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3—4 раза в день

- Rp. Dec. rad. Senegae 6,0—180,0 Liq. Ammonii anisati 4,0
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
Rp. Dec. rad. Senegae 3,0—180,0
Natrii benzoici Liq. Ammonii anisati aa 1,0 S'r. Liquiritiae 20,0
MDS. По 1 десертной ложке 4—5 раз в день (детям 5—8 лет)
Rp. Inf. herbae Thermopsidis 0,6—180,0 Liq. Ammonii anisati 4,0 MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
Rp. Inf. Polemonii cnerulei 6,0—180,0 L'g. Ammonii anisati 4,0 MDS. По 1 столовой ложке через 3—4 часа
Rp. Inf. herbae Ledi palustris 10,0 — 200,0 DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
Rp. Extr. Thermopsidis 0,01 -Extr. Opii 0,005 Natrii bicarbonici 0,3 M. f. pulv.
D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день
Rp. Terpini hydranti 0,3
Codeini phosphorici 0,02 M. f. pulv.
D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день
Rp. Inf. rad. Azari eurnpaci 2,0 : 180,0 Liq. Ammonii anisati 4,0 MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
Rp. Decocti rad. Senegae sibiricae 8,0 : 200,0 Liq. Ammonii anisati 4,0 MBS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Протяво кашле вые средства

- Rp. Codeini phosphorici 0,02
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день
Rp. Sol. Codeini phosphorici 2% 15,0 DS.
По 20 капель 2—3 раза в день

- Rp. Dionini 0,01
Saocchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 2—3 раза в день
- Rp. Dionini 0,1
Aq. Laurocerasi 10,0
MDS. По 15—20 каплей 2—4 раза в день

Антисептики легких

- Rp. Guajacoli carbonici 0,5 D. t. d. N. 12 S.
По 1 порошку 3—4 раза в день
- Rp. Kreosoti 3,0
Extr. et pulv. Liquiritiae
q. s. ut f. pil. N. 30
DS. По 1 пилюле 3—4 раза в день
- Rp. Kreosoti 5,0
T-rae Gentianae 15,0
MDS. По 20 каплей 3 раза в день
- Rp. Sirolini 100,0
DS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день
- Rp. Thiocoli 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 3—4 раза в день

Прижигающие средства

- Rp. Ac. acetici glacialis 5,0
DS. Наружное, для прижигания
- Rp. Ac. lactici 30—40—50—60% 10,0
DS. Для прижигания
- Rp. Ac. trichloroacetic! 5,0 DS.
Для прижигания
- Rp. Argenti nitrici fusi 1,0 in bacillo DS. Для
прижигания
- Rp. Cuprialuminati fusi 1,0 in bacillo
DS. Для прижигания слизистой оболочки глаз
- Rp. Bacilli Cupri sulfurici! 1,0
DS. Для прижигания трахоматозного конъюнктивита

Потогонные средства

- Rp. Inf. florum Chamomillae 10,0—200,0
DS. По полстакана в горячем виде 3—4 раза в день Rp.
- Inf. fructus Rubi idaei 20,0—200,0
DS. По 1 стакану в горячем виде 2—3 раза в день

- Rp. Inf. florum Sambuci 20,0—200,0
DS. По $\frac{1}{2}$ стакана в горячем виде 4—5 раз в день
- Rp. Inf. florum Tiliae 20,0—200,0
DS. По 1 стакану в горячем виде 2—3 раза в день

Противоанемические средства

- Rp. Ac. arsenicosi 0,06 Ferri lactici 12,0 Extr. et pulv.
Liquiritiae q. s. ut f. pil. N. 60 DS. По 1 пилюле 3
раза в день после еды
- Rp. Sol. arsenicalis Fowled 5,0 T-rae Ferri pomrti 20,0 MDS. По
10—25 каплей 3 раза в день после еды
- Rp. Sol. Natrii arsenicici 1% 1,0 D. t. d. N.
30 in amp. S. Для подкожных
инъекций
- Rp. Sol. arsenicalis Fowleri 5,0 T-rae Chinae compositae 20,0
MDS. По 10—25 каплей 3 раза в день после еды
- Rp. Ac. arsenicosi
Cupri sulfurici aa 0,05
Ferri glycerinophosphorici 5,0
Extr. et pulv. Liquiritiae
q. s. ut f. pil. N. 50
DS. По 1 пилюле 3—4 раза в день после еды
- Rp. Natrii arsenicici 0,2
Sol. Ac. carbolicci 0,5% 20,0
Sterilisetur!
DS. Под кожу, сначала 0,1—0,2 мл, затем, прибавляя
ежедневно по 0,1 мл, довести до 1 мл и так вводить
10 дней
- Rp. Ac. arsenicosi 0,06 Ferri reducti 12,0 Extr. et pulv.
Liquiritiae q. s. ut f. pil. N. 60 DS. По 1 пилюле 3—4
раза в день после еды
- Rp. Ferri lactici 0,3 D. t. d. N. 30 S. По 1 порошку 2—3 раза в
день во время еды
- Rp. Pilulae Blaudii N. 100
DS. По 1—2 пилюли 3 раза в день во время еды
- Rp. Ferri glycerophosphorici 0,3 D. t. d.
N. 30 S. По 1 порошку 3 раза в
день

- Rp. Ferri reducti Leeithini aa 6,0 Phytini 4,0 Massae pilularum q. s. ut f. pil. N. 60 DS. По 1 пилюле 3 раза в день во время еды
- Rp. Liq. Ferri albuminati 200,0 DS. По 1 десертной ложке на полстакана воды (молока) 3 раза в день во время еды
- Rp. Liq. Ferri albuminati 200,0 Sol. arsenicalis Fowleri 2,0 MDS. По 1 десертной ложке 2—3 раза в день во время еды
- Rp. Haematogeni 200,0 DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день во время еды
- Rp. Tabulettae Haematogeni N. 100 S. По 1—2 таблетки 3 раза в день во время еды
- Rp. Hepaloni 1,0 D. t. d. N. 12 in amp. S. По 1 ампуле в мышцу
- Rp. Hepatini 2,0 D. t. d. N. 12 in amp. S. По 2 мл в мышцу (1 раз в день)

Противогонорройные средства

- Rp. Argenti nitrici 0,03 Aq. destill. 200,0 MDS. Для спринцеваний *
- Rp. Sol. Hydrargyri oxysuccinati (1 : 2 000) 200,0 DS. Для спринцеваний
- Rp. Sol. Kalii permanganici (1 : 2 000—1 : 3 000) 200,0 DS. Для спринцеваний
- Rp. Penicillini 100 000 ME S. Через каждые 3 часа по 50 000 ME внутримышечно
- Rp. Sol. Plumbi acetici (1 : 500) 200,0 DS. Для спринцеваний
- Rp. Sol. Protargoli 0,5—1% 200,0 DS. Для спринцеваний
- Rp. Sol. Rivanoli (Acricidi) (1 : 1 000) 200,0 DS. Для спринцеваний

- Rp. Streptocidi albi 0,5 D. t. d. N. 60 S. По 1 порошку 6 раз в день в течение 6 дней подряд, затем по 1 порошку 4 раза в день в течение 6 дней подряд
- Rp. Sulfacili (Albucidi) 0,3—0,5 D. t. d. N. 30 S. По 1 порошку 5 раз в день в течение 6 дней
- Rp. Sulfidini 0,5 D. t. d. N. 44 S. По 1 порошку 8 раз в день в течение 3 дней, затем по 1 порошку 6 раз в день в течение 2 дней и, наконец, по 1 порошку 4 раза в день в течение 2 дней
- Rp. Sulfazoli seu Norsulfazoli 0,5 D. t. d. N. 30. S. По 1 порошку 5 раз в день в течение 6 дней
- Rp. Zinci sulfurici Plumbi acetici aa 0,3 Aq. destill. 200,0 MDS. Для спринцеваний
- Rp. Anaesthesini 0,2 Xeroformii 0,1 But. Cacao 2,0 M. f. supp. D. t. d. N. 6 S. По 1 свече 2 раза в день

Противогеморроидальные средства

- Rp. Anaesthesoli (in scatula originale) S. По 1 свече 2 раза в день
- Rp. Anusoli (in scatula originale) S. По 1 свече 1—2 раза в день
- Rp. Dermatoli 0,2 Extr. Belladonnae 0,015 But. Cacao 1,5 M. f. supp. D. t. d. N. 6 Si По 1 свече утром и вечером в прямую кишку >

Противоглистные средства

- Rp. Seminis Cinae 10,0 DS. По 2,0—3,0—5,0 в смеси с медом или сиропом (при аскаридах)
- Rp. Seminis Cucurbitae Pepo decorticati 100,0—300,0 DS. На прием per se или в виде эмульсии против ленточных глистов

- Rp. Extr. Filicis maris 0,5—0,6
D. t. d. N. 10 in caps, gelatinosis
S. Принимать по 1 капсуле через каждые 5 минут; затем спустя 60—90 минут после последнего приема — слабительное (против ленточных глистов)
- Rp. Extr. Cort. Granati fluidi 30,0
DS. По 30—40 капель 3—4 раза в день (против ленточных глистов)
- Rp. Hexylresorcini 0,2
D. t. d. N. 5 in caps.
S. Принять 5 капсул, не разжевывая их (при аскаридах и анкилостомах)
- Rp. Osarsoli 0,25
D. t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день 4 дня подряд (против власоглава)
- Rp. Santonini 0,05—0,075
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 9
S. По 1 порошку 3 раза в день 3 дня подряд (при аскаридах)
- Rp. Santonini 0,02
D. t. d. N. 9 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день 3 дня подряд ребенку 4—5 лет (против аскарид)
- Rp. Xeroformii 0,3
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 2 раза в день в течение 7 дней в комбинации со слабительными и клизмами (против остриц)
- Rp. Santonini 0,05 «
Calomelanos 0,03 Pulv. Rhei
0,25 M. f. pulv. D. t. d. N. 9
S. Принимать 3 раза по утрам через 2 часа (8, 10, 12 часов) в течение 3 дней (против аскарид)
- Rp. Sancafeni in tabl. D. t. d. N. 20 S.
8—10 таблеток в день 2 дня
подряд (взрослым)

Противомалярийные средства

- Rp. Acrichini 0,1
D. t. d. N. 15 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день

- 6 Rp. Sol.
Acrichini hydrochlorici 2% 30,0 Sterilisetur! DS.
По 10 мл в мышцу 1 раз в день
- Rp. Chinini hydrochlorici 0,3 D. t. d. N.
15 in tab. S. По 1 таблетке 3 раза в день
- Rp. Chinini hydrochlorici 0,3 Methyleni
coerulei 0,05 M. f. pulv. D. t. d. N. 12
in obi. S. По 1 облатке 3 раза в день
- Rp. Chinini hydrochlorici 3,0
Antipyrini 2,0 Aq. destill. 6,0
Sterilisetur! MDS. По 1 мл под
кожу
- Rp. Novarsenoli 0,15—0,3—0,45—0,6
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для введения в вену в растворе (1:20)
- Rp. Osarsoli 0,25 *
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день
- Rp. Plasmocidi 0,01
Acrichini 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 3 раза в день
- Rp. Plasmocidi 0,01
Osarsoli 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день Rp.
- Plasmocidi 0,01
Chinini hydrochlorici 0,5
M. l. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день Rp.
- Bigumali 0,1—0,2
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день в течение 7—10 дней (п)и
трехдневной форме малярии, особенно эффективен при
лечении тропической малярии) Rp. Chinini hydrochlorici
Ac. hydrochlorici diluti aa 3,0
Aq. Menthae 150,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день Rp.
- Chinini bihydrochlorici 1,0
Sol. Natrii chlorati 0,9% 20,0
Sterilisetur!
MDS. По 10 мл в вепу

Противопаразитарные и инсектицидные против насекомых средства

- Rp. Aceti Sabadillae 100,0
DS. Для обтирания волосистых частей тела при вшивости
- Rp. Antipediculini СК
DS. В виде 2% эмульсии, 10% мази, 10% дуста (против вшивости)
- Rp. Balsami Peruviani 20,0
Spiritus Vini 100,0
MDS. Для втирания в кожу при паразитарных заболеваниях
- Rp. Saponis K
DS. В виде 2% эмульсии для замочки белья (против вшивости)
- Rp. Diphenylamini ДФА 15,0
DS. По 7,0—8,0 порошка на 1 пару белья (против вшивости)
- Rp. Lysoli 5,0
Aq. destill. ad 200,0 MDS.
Для дезинфекции
- Rp. Naphtalini 100,0
DS. Против различных насекомых (блох, клопов, моли)
- Rp. Ung. Wilkinsoni 50,0
DS. Мазь против чесотки
- Rp. Pulv. Pyrethri 30,0
DS. Против различных насекомых
- Rp. Solventi 100,0 %
DS. Жидкость против вшей, клопов, блох и др.
- Rp. Sulfolani 50,0
DS. Мазь против чесотки
- Rp. Thiolani 50,0
DS. Мазь для лечения кожных заболеваний (экземы, зуд, сыпь)
- Rp. Ung. Sulfurati simplicis 100,0 DS.
Мазь против чесотки
- Rp. Aceti Veratri 50,0
DS. Для обтирания волосистых частей тела при вшивости
- Rp. Pulveris DDT 30,0
DS. Против различных насекомых

Противоподагрические средства

- Rp. Atophani 0,5
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1—2 таблетке 3 раза в день после еды, запивая стаканом боржома
- Rp. Colchicini 0,03
Extr. et pulv. Liquiritiae ut f. pil. N. 30
DS. По 1—2 пилюли во время приступа подагры
- Rp. T-rae Colchici 45,0
DS. По 15—20 капель 3 раза в день
- Rp. Lithii carbonici 0,25
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день, запивая щелочной водой
- Rp. Lithii salicylici 6,0 Aq.
destill. 180,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день, запивая щелочной водой
- Rp. Pipererazini 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

Противорвотные и противотошнотные средства

- Rp. Anaesthesini 0,3 D. t. d.
N. 6 S. По 1 порошку 1-2 раза в день перед едой
- Rp. Aq. Amygdalarum amararum 15,0
DS. По 15—20—30 капель 3—4 раза в день
- Rp. Aq. Chloroformii
Aq. Menthae aa 100,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
- Rp. Chloroformii 3,0
T-rae Vahrianae
Spifitus Vini aa 10,0
MDS. По 20 капель на прием
- Rp. Sol. Kalii bromati 3% 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
- Rp. Spiritus Mentholi 10% 15,0
DS. По 20—30 капель на прием 2—3 раза в день (при рвоте)
- Rp. T-rae Menthae pip. 15,0
DS. По 15—20 капель на прием

Rp. T-rae Valerianae aetherae 10,0

DS. По 15—20 капель 3 раза в день

Противосифилитические средства

Rp. Bijochinoli 10% 30,0

DS. По 2—3 мл в мышцу через 2—3 дня. **За курс**
лечения вводят 40 мл

Rp. Bismoveroli 20,0

DS. По 1 мл в мышцу через 2—3 дня, всего 15—20 инъекций

Rp. Hydrargyri bijodati 0,1 Kalii jodati 3,0 Ад. destill.

150,0 MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Galomelanos

Talci puri aa 5,0

M. f. pulv.

DS, Присыпка (при сифилитических язвах)

Rp. Hydrargyri salicylici 1,0 01. Vaselinei sterilisatae 10,0

MDS. По 0,5—1 мл в мышцу 2 раза в неделю

Rp. Ung. Hydrargyri cinerei 3,0 D. t. d. N. 12 in charta

cerata S. Втирать в кожу ежедневно одну порцию

Rp. Sol. Mercusali 10% 1,0 D. t. d. N. 6 in

amp. S. По 1 мл в мышцу через 1—2 дня

Rp. Novarsenoli (Neosalvarsani) 0,15—0,3—0,45—0,6 D. t. d.

N. 6 in amp. S. Для введения в вену в растворе (1 : 20)

Rp. Myarsenoli (Myosalvarsani) 0,15—0,3—0,45—0,6 D. t. d.

N. 6 in amp. S. Для введения в мышцу в растворе (1 : 20)

Rp. Osarsoli 0,25

D. t. d. N. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp. Penicillini 200 000 ME D. t.

d. N. 15 in vitro

S. По 20 000—50 000 ME внутримышечно 6 раз в день в течение 10 дней и более

Противоспазматические средства

Rp. Amylii nitrosi 0,2 D. t. d. N. 6 in amp. S. Сломать
ампулу в носовом платке, вдыхать

Rp. Amylii nitrosi

Chloroformii aa 3,0

MDS. По 5—6 капель на вату или платок для вдыхания

Rp. Sol. Nitroglycerin! 1% 5,0

DS. По 2—3 капли на прием 2 раза в день (при грудной
жабе)

Rp. Angiotrophini 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день

Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 15,0

DS. По 8—10 капель 3 раза в день перед едой

Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S.

По 0,5—1 мл под кожу 1—2 раза в день

Rp. Atropini sulfurici 0,005

Papaverini hydrochlorici . 0,2

Aq. destill. 10,0

Sterilisetur!

MDS. По 1 мл под кожу

Rp. Atropini sulfurici 0,00025

Papaverini hydrochlorici 0,02

Sacchari 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp. Atropini sulfurici 0,015

Papaverini hydrochlorici 0,45 Extr. et

pulv. Valerianae q. s. ut f. pil. N. 30 S.

По 1 пилюле 2—3 раза в день

Rp. T-rae Belladonnae 10,0

DS. »no 10—15 капель 2—3 раза в день

Rp. Extr. Belladonnae 0.015 Saloli

0,5

M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1

порошку 3 раза в день

Rp. Extr. Belladonnae 0,015

Papaverini hydrochlorici 0,02

Sacchari 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

- Rp. Saloli
Urotropini aa 0,3
Extr. Belladonnae 0,015
M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Extr. Belladonnae 0,05
Aq. Amygdalarum amararum 10,0
MDS. По 1 капле на год жизни ребенка 3 раза в день
- Rp. Extr. Belladonnae 0,015 Extr. Opii 0,02 But.
Cacao 1,5 M. f. supp. D. t. d. N. 6 S. По 1 свече на ночь в прямую кишку
- Rp. Extr. Belladonnae 0,015
Papaverini hydrochlorici 0,02
Omnoponi 0,01
But. Cacao 1,5
M. f. supp. D. t. d. N. 6
S. По 1 свече на ночь в прямую кишку
- Rp. Ephedrini hydrochlorici 0,025
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Sol. Lidoli 1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 0,5—1 мл под кожу
- Rp. Sol. Magnesii sulfurici 10%
Sol. Glucosi 20% aa 15,0
Sterilisetur!
MDS. По 10—15 мл в Еену
- Rp. Sol. Omnoponi 2% 1,0 D. t. d. N. 3 in amp. S. По 1 мл под кожу
- Rp. Papaverini hydrochlorici 0,03 Extr. Belladonnae 0,015 Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Platyphyllini bitartarici 0,003
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

«

- Rp. Inf. rad. Valerianae 8,0—200,0 Extr. Belladonnae 0,1 MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Противоядна

- Rp. Amylii nitrosi 5,0
DS. Вдыхать при отравлении цианидами
- Rp. Antidoti arsenici 300,0
DS. По 1 столовой ложке через 5—10 минут
- Rp. Antidoti metallorum 100,0
DS. По 100 мл на прием при лечении острых отравлений тяжелыми металлами, особенно при отравлении сулемой
- Rp. Methyleni coerulei 1,0
Sol. Glucosi 20% 100,0
Sterilisetur!
MDS. По 50 мл в вену (при отравлении цианидами, окисью углерода)
- Rp. Sol. Natrii hyposulfurosi 30% 50,0 D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 50 мл в вену (при отравлении синильной кислотой и ее солями)

Раздражающие кожу средства

- Rp. Spiritus camphorati 100,0 DS. Для растирания кожи
- Rp. 01. Camphorati 01. Terebinthinae Chlcrofermii aa 20,0 MDS. Для растирания кожи
- Rp. Emplastri Cantharidis q. s. extende supra emplastrum adhaesivum magnitudinis designatae 6X8 cm
DS.« Мухка
- «
- Rp. Darmiaoli
Methylii salicylici aa 20,0
MDS. Для легкого втирания в кожу (при ревматизме, невралгии)
- Rp. Linimenti ammoniati camphorati 50,0 DS. Для растирания кожи
- Rp. Linimenti saponato-camphorati 30,0 Methylii salicylici 20,0 MDS. Для растирания кожи

- Rp. Spiritus Sinapis 30,0 DS.
Растирание
- Rp. Chartae Sinapis D. t. d.
N. 3
S. Перед прикладыванием к коже смачивать горчичник
теплой водой (не кипятком)
- Rp. Ung. Terebinthinae 30,0
DS. Втирать в кожу груди (при бронхите)
- Rp. Ol. Terebinthinae 10,0 Methyl salicylici 15,0 Lanolini
ad 50,0 M. f. linimentum DS. Втирать в кожу
суставов (при артритах)
- Rp. Spiritus Formicarum Spiritus Sinapis
Spiritus saponatus aa 20,0 MDS.
Для растирания кожи

Расширяющие зрачок средства

- Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,5% 5,0 DS.
Глазные капли
- Rp. Sol. Hyoscyamini sulfurici 0,25% 5,0 DS.
Глазные капли
- Rp. Sol. Homatropini hydrobromici 1% 5,0 DS.
Глазные капли.

Рвотные средства

- Rp. Sol. Apomorphini hydrochlorici sterilisatae 1% 5,0 DS.
По 0,5 мл под кожу
- Rp. Sol. Cupri sulfurici 1% C0,0 *
DS. По 1 столовой ложке через 5—10 минут до насту-
пления рвоты
- Rp. Sol. Zinci sulfurici 1% 60,0
DS. По 1 столовой ложке через 5—10 минут до на-
ступления рвоты

Сердечные и сосудосуживающие средства

- Rp. Adonileni 15,0
DS. По 15—20 капель 3—4 раза в день
- Rp. Inf. Adonidis vernalis 6,0—180,0
DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
- Rp. Sol. Adrenalin hydrochlorici (1 : 1 000) 0,5
Sol. Natrii chlorati isotonicae sterilisatae 500,0 MDS.
Для введения в вену. Готовится ex tempore

- Rp. Camphorae tritae 0,2
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 in charta cerata S. По 1
порошку 3—4 раза в день
- Rp. Ol. Camphorati 20% 1,0 D. t. d. N. 10
in amp. S. По 1 мл через 1—2—3 часа
- Rp. Coffeini natrio-benzoici 0,1—0,2 D. t. d. N. 6
in tab. S. По 1 таблетке 2—3—4 раза в день
- Rp. Sol. Coffeini natrio-benzoici 20% 1,0 D. t. d. N. 6 in
amp. S. По 1 мл под кожу 2—3—4 раза в день
- Rp. Chinidini sulfurici 0,2 D. t.
d. N. 12
S. По 1 порошку 2—3 раза в день (при мерцательной
аритмии)
- Rp. T-rae Convallariae majalis 10,0 T-rae
Valerianae aetherae 15,0 MDS. По 20—25
капель 3 раза в день
- Rp. Convasidi 1,0
D. t. d. N. 3 in amp.
S. По 0,5—1 мл под кожу 1 раз в день
- Rp. Sol. Corasoli 10% 1,0 D. t. d. N. 6 in
amp. S. По 1 мл под кожу или в вену
- Cordiamini 1,0
Rp. D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл под кожу или в вену
- Cordiamini 15,0
Rp. DS. По 30—40 капель ,3—4 раза в день
- Cordigiti N. 10 in tab.
Rp. DS. По половине таблетки 2 раза в день
- Digalen-Neo 1,0
Rp. D. t.'d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл под кожу
- Diginormi 15,0
Rp. DS. По 15—20 капель 3 раза в день
- Pulv. folii Digitalis 0,05
Rp. Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день
- Inf. folii Digitalis 0,6—180,0
Rp. DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

- Rp. Inf. folii Digitalis 0,6—180,0 Diuretini 4,0—6,0
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день
- Rp. Pulv. folii Digitalis 0,1 But. Cacao 1,5 M. f. supp.
D. t. d. N. 12 S. По 1 свече в прямую кишку 3 раза в день
- Rp. Gitaleni 15,0
DS. По 10—15 —20 капель 3 раза в день
- Rp. Tabul. Ephedrini hydrochlorici 0,025 D. t.
d. N. 10 S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
- Rp. Sol. Ephedrini hydrochlorici 5% 1,0 D. t.
d. N. 6 in amp. S. По 0,5—1 мл под кожу
- Rp. Sol. Glucosi sterilisatae 40% 50,0 D. t.
d. N. 3 in amp. S. Для введения в вену
- Rp. Sol. Glucosi 5% 200,0 DS. На 1 клизму
- Rp. Sol. Glucosi sterilisatae 5% 200,0 DS. Для введения под кожу
- Rp. T-rae Strophanthi 5,0
T-rae Valerianae aetherae 15,0
MDS. Принимать по 20—25 капель 3 раза в день
- Rp. Sol. Strophanthini (1:1000) 1,0 D. t. d. N. 3 in amp.
S. По 0,25—0,5 мл в вену (вводить медленно)
- Rp. T-rae Strophanti^
T-rae Strychni aa 5,0 »
T-rae Valerianae aetherae 10,0
MDS. По 15—20 капель 3 раза в день
- Rp. T-rae-Strophanthi 0,05 Sol. Glucosi 40% 20,0 Sterilisetur! MDS. Для введения в вену
- Rp. Sol. Stypnoni 5»/о 10,0
DS. По 15—20 капель i—2 раза в день
- Rp. Sol. Stypnoni 0,5% 1,0 D. t. d. N. 3 in amp.
S. Ilo 1—2 мл под кожу
- Rp. Sol. Vasotoni 5% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S.
По 1 мл под кожу 1—2 раза в день

III

- Rp. Sol. Vasotoni 10% 10,0
DS. По 15—20 капель 3 раза в день

Слабительные средства см. *Желудочно-кишечные средства*
Слизистые и обволакивающие средства

- Rp. Mucilaginis Amyli 100,0 T-rae
Opii gtt. X MDS. На 1 клизму
- Rp. Amyli tritici
Amyli oryzae aa 15,0
M. f. pulv. DS. Пудра
- Rp. Gelatinae albae
Sir. simplicis aa 10,0 Aq\ destill. 100,0
MDS. По 1 столовой ложке через 1—2 часа (при желудочных кровотечениях)
- Rp. Gelatinae albae 10,0 Aq. destill. 100,0 MDS. На 2 клизмы
- Rp. Decosti seminis Lini 200,0 DS.
Припарки
- Rp. Mucilaginis Gummi arabici 30,0 Sir. simplicis 20,0 Aq. destill. ad 200,0
MDS. По 1 столовой ложке через 2 часа (обволакивающее)
- Rp. Mucilaginis Salop 100,0
DS. По 1 чайной — 1, десертной ложке 3—4—5 раз в день (обволакивающее при поносах)
- Rp. Emuls. Amygdalarum dulcium 200,0
DS. По 1 столовой ложке 5—6 раз в день (обволакивающее при желудочных заболеваниях)
- Rp. Emuls. Seminis Cannabis 200,0
DS. По 1 столовой ложке 5—6 раз в день (обволакивающее при желудочных заболеваниях)

Снотворные средства

- Rp. Adalini 0,5—1,0 D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку на ночь в стакане горячего чая
- Rp. Bromurali 0,5
D. t. d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

- Rp. Chloral! hydrati 4,0 Mucilaginis Amyli Aq. destill. aa 30,0 MDS...По 1 столовой ложке на ночь
- Rp. Chlorali hydriti C,0
Mucilagini" Gummi arabici
Aq. destill. aa 50,0
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день при белой горячке
- Rp. Chlorali hydrati 1,0
Mucilaginis Amyli Aq. destill. aa 20,0 MDS. На 1 клизму
- Rp. Chlorali hydrati 1,0 Natrii bromati Extr. Liqiiiritiae aa 2,0 Aq. destill. 100,0
MDS. По половине чайной ложки через 1 час (детям раннего возраста при возбуждении)
- Rp. Barbamyli 0,3 D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку на ночь (при бессоннице)
- Rp. Barbamyli 1,0
Sol. Natrii chlorati isotonicae 100,0 MDS. Вводить в прямую кишку 2 раза в день по 50 мл pro dosi (для длительного сна при психических заболеваниях).
- Rp. Luminali 0,05—0,1 " D. t. d. N. 6 in tab. S. По 1—2 таблетки на ночь
- Rp. Luminali-Natrii 2,0 Aq. destill. 10,0 Sterilisetur!
MDS. По 0,5—1 мл под кожу 1 —2 раза в день при сильном возбуждении
- Rp. Sol. Medinali 10% 5,0 D. t. d. N. 3 in amp. S. По 5 мл внутримышечно (при шизофрении)
- Rp. Paraldehydi 5,0
Mucilaginis Amyli 75,0 Sir.
Auranti ad 100,0 MDS. На 2 приема на ночь
- Rp. Paraldehydi 3,0
Mucilaginis Salep 100,0
MDS. На 1 клизму

- » Rp. Sonbutali
(Pernoctoni) 10% 5,0 D. t. d. N. 2 in amp. S.
По 2 мл в вену
- Rp. Pronarconi (Eunarconi) 10% 5,0 D. t. d. N. 2 in amp. S. По 3—5 мл в вену
- Rp. Quietali (Noctali) 0,3 D. t. d. N. 6 in tab. S. По 1 таблетке на ночь
- Rp. Rectoni (Rectidoni) 10% 10,0 D. t. d. N. 2 in amp. S. 4—5—6—7 мл вводится в прямую кишку
- Rp. Veronali 0,5
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке на ночь
- Rp. Veronali 0,3 Luminali 0,1 M.
f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку на ночь
- Rp. Medinali 0,5 But. Cacao 1,5 M. f. supp. D. t. d. N. 3 S. По 1 свече в прямую кишку на ночь
- Сосудорасширяющие средства
- Rp. Acetylcholini 0,1—0,2 D. t. d. N. 3 in amp. S. Растворить ex tempore в стерильной дистиллированной воде и ввести в дозе 0,02—0,05—0,1 pro die под кожу или в мышцу
- Rp. Amylii nitrosi
Chloroformii aa 3,0
MDS. По 5—6 капель на вату или платок для дыхания
- Rp. Angiotrophini 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
4. По 1 мл 1—2 раза в день под кожу »
- Rp. Sol. Benzolini 1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp.
5. По 1 мл 1—2 раза в день под кожу
- Rp. Sol. Carbocholini (1:10 000) 1,0 D. t. d. N. 6 in amp.
S. 0,5—1 мл под кожу
- Rp. Sol. Natrii nitrosi sterilisatae 2% 15,0
DS. По 1—2 мл в мышцу (при гипертонии)

- Rp. Sol. Nitroglycerin! 1% 5,0
DS. По 2—3—5 капель на прием
- Rp. Papaverini hydrochloric! 0,03 Diuretini 0,5
Luminali 0,015 M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 3 раза в день после еды
- Rp. Salsolini hydrochlorici 0,03
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1
порошку 3 раза в день
- Rp. Sol. Salsolini hydrochlorici 1% 10,0 Sterilisetur!
DS. По 1 мл 1—2 раза в день под ксжу
- Rp. Sol. Atropini sulfurici 1% 10,0 DS. По 2
капли 2—4 раза в день
- Rp. Sol. Homatropini hydrobromici 1% 10,0
DS. Впускать по 1 капле в глаз для расширения
зрачка с диагностической целью
- Суживающие зрачок средства
- Rp. Sol. Carbocholini (1 : 1 000) 5,0 DS.
Глазные капли
- Rp. Sol. Physostigmini salicylici 0,5% 5,0 DS.
Глазные капли
- Rp. Sol. Pilocarpini hydrochlorici 1—2% 5,0 DS.
Глазные капли
- Rp. Sol. Proserin) 0,25% 10,0
DS. По 2 капли 2—3 раза в день «
- Rp. Sol. Furamoni 3 — *ifij* 10,0
DS. Закапывать в больной глаз по 2 капли 5—6 раз в
день и один раз ночью
- Укрепляющие и действующие на обмен веществ средства
- Rp. Ac. arsenicosi 0,06 Ferri lactici 12,0
Extr. et pulv. Liquiritiae q. s. ut
f. pit. N. 60
DS. По 1 пилюле 3 раза в день после еды (при упадке
питания)
- Rp. Ac. ascorbinici 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20 S. По 1 порошку
2—3 раза в день

- Rp. Sol. Ac. ascorbinici 5% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1
мл в вену 1 раз в день
- Rp. Antithyroidini 0,1 D. t. d.
N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день (при базедовой болезни)
- Rp. Sol. Calcii glycerophosphorici Ferri
glycerophosphorici aa 0,25 M. f. pulv. D.
t. d. N. 20 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Sol. Glucosi sterilisatae 40% 50,0 D. t.
d. N. 6 in amp. S. Для введения в вену
- Rp. Haematogeni 200,0
DS. По 1 десертной ложке 3 раза в день перед едой
- Rp. Insulini 5,0
DS. По 10—20 единиц под кожу или в мышцу перед едой
- Rp. Lecithini
Ferri lactici aa 5,0
Extr. Taraxaci q. s. ut pil. N. 60
DS. По 1 пилюле 3 раза в день
- Rp. Sol. Natrii an-epicici 1% 1,0 D. t. d.
N. 10 in amp. S. Для введения под
кожу
- Rp. 01. jecoris Aselli 200,0
DS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день (детям 3—6
лет)
- Rp. Pnytini 0,25
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день
- Rp. Sol. arsenicalis Fowleri 5,0 T-rae
Ferri pomati 15,0
MDS. По 10—15—20 капель 3 раза в день во время
« еды »
- Rp. Spermini 30,0
DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой
- Rp. Carotoli 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл под кожу Rp. Sol. Thiamini
(Vitamin B₁) 0,6% 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл под кожу 1 раз в день

- Rp. Tabulettae Torulini 0,5
D. t. d. N. 12
S. По 1 таблетке в день за час до еды Rp.
- Vitaminoli 10,0
DS. По 5 капель 1 раз в день в ложке теплого молока
(ребенку 4—5 лет)
- Успокаивающие нервную систему средства
- Rp. Adalini 0,3
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день
- Rp. Analgini 0,3 D.t. d. N. 12 S. По 1
порошку 2—3 раза в день
- Rp. Bromurali 0,3
D.t. d. N. 12 in tab.
S. По 1 таблетке 2 раза в день
- Rp. Camphorae monobromatae 0,25 D. t. d. N.
10 in caps, gelat. S. По 1 капсуле 2—3
раза в день
- Rp. Clorali hydrati 1,5
Extr. rad. pulv. Valerianae
q. s. ut f. pil. N. 30
S. По 1 пилюле 3 раза в день во время еды
- Rp. Diphenini 0,1—0,15—0,2
D. t. d. N. 12
S.. По 1 порошку 3 раза в день после еды Rp.
- Sol. Kalii bromati 6,0—180,0
DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день
- Rp. Sol. Kalii bromati 6,0—180,0
Extr. Leonuri cardiacae fluidi 6,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день
- Rp. Sol. Natrii bromati 6,0—180,0 T-rae
Valerianae 6,0 MDS. По 1 столовой ложке 3
раза в день
- Rp. Luminali 0,05
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день
- Rp. Inf. rad. Valerianae 8,0—180,0
Natrii bromati 8,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день Rp.
- Validoli 10,0
DS. По 5—10 капель на кусочке сахара 1—2—3 раза в
день

- Rp. Zinci valerianici 1,5
Extr. et pulv. Valerianae
q. s. ut f. pil. N. 30
DS. По 1 пилюле 3 раза в день
- Rp. Zinci valerianici 0,05
Camphorae monobromatae 0,2
Sacchari 0,3
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 in charta cerata
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Этиотропные., или хлшшотерапевтпческпе, средства

Препараты ртути как антисептические, противопаразитарные и
противосифилитические средства см. соответствующие разделы.

- Rp. Acrichini 0,1
D. t. d. N. 15 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день (для профилактики и
лечения малярии). На половые формы (гамето-циты)
не действуют
- Rp. Bijochinoli 40,0
DS. По 1—2 мл через день внутримышечно (для пе-
чения всех форм сифилиса)
- Rp. Bismoveroli 20,0
DS. По 1 мл в мышцу через 2—3 дня, всего 15—20
инъекций
- Rp. Chinini hydrochlorici 0,25 D. t. d. N. 12 in tab. S. По 1
таблетке 3—4 раза в день (для профилактики
и лечения малярии). На половые формы (гамето-
циты) не действует
- Rp. Chinini hydrochlorici 3,0
Antipyrini 2,0 Aq. destill. 6,0
Sterilisetur! MDS. По 1 мл
под кожу
- Rp. Disulfani 0,5—1,0
JP. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 4—6 раз в день (при бациллярной
дизентерии и гоноррее)
- Rp. Sol. Emetini hydrochlorici 5% 15,0
Sterilisetur!
DS. По 0,5—1 мл под кожу 1—2 раза в день (для
лечения амёбной дизентерии)
- Rp. Sol. Gramicidini spirituosii 4% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S.
Применяют только местно. Перед употреблением

исходный спиртовой раствор разводится стерильной дистиллированной водсй в 100 или 50 раз (при гнойных ранах мягких тканей, остесмиэлитях, эмпиемах, нагноении после ожогов)

Rp. Myarsenoli 0,15—0,3—0,45—0,6

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Для введения под кожу или в мышцу после соответствующего растворения содержимого 1 ампулы в 20-кратном количестве стерильной дистиллированной воды

Rp. Novarsenoli 0,15—0,3—0,45—0,6

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Растворить соответствующее содержимое 1 ампулы в 20-кратном количестве свежедистиллированной воды и ввести только в вену

Rp. Osarsoli 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. Принимать по указанию врача

Rp. Penicillini 200 000 ME D. t.

d. N. 6

S. Внутримышечно равными частями через 4 часа (при гоноррее)

Rp. Plasmocidi 0,01

Acrichini 0,1

M. f. pulv. D. t. d. N.: 36 in tab.

S. По 1 таблетке 3 раза в день Rp.

Plasmocidi 0,01

Chinini sulfurici 0,4

M. f. pulv. D. t. d. N. 36

S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Sulfacili 0,3—0,5—1,0

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3—4—5 раз в день (при стафилококковой инфекции) Rp. Sulfacili solubilis 10—20—20% 10,0

DS. Для лечения бленорреи новорожденных и инфицированных язв роговицы Rp. Sulfasoli 0,5—1,0

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3—4—5 раз в день Rp.

Sulfidini 0,5—1,0

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3—4—5 раз в день Rp.

Norsulfasoli 0,5—1,0

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 4—6 раз в день (при пневмонии, гоноррее)

Органо- и гормонопрепараты

AdrenaTinum см. *Кровоостанавливающие, противоспазматические, сердечные и сосудосуживающие средства.*

Rp. Adiureerini 0,05 D.

t. d. N. 10

S. По 1 порошку вводить в нос 1—2 раза в день (при несахариом диабете)

Rp. Cortini 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день (при миастении, адДисоновой болезни)

Rp. Folliculini 1,0 (1000ЕД) D. t. d.

N. 6 in amp.

S. По 1 мл под кожу или в мышцу ежедневно в течение 20—30 дней

Rp. Folliculini-benzoati 5 000—10 000 ЕД in amp. D. t. d.

N. 20

S. 2—3 раза в неделю по 5 000 единиц через 1—2 дня под кожу

Haematogenum, Hepalonum см. *Противоанемические, укрепляющие и действующие на обмен веществ.*

Rp. Sol. Histidini 4% 5,0" D. t.

d. N. 12 in amp.

S. По 5 мл в мышцу в день (при язве желудка и двенадцатиперстной кишки)

. Histo-Zink-Insulinum см. *Укрепляющие и действующие на обмен веществ — Insulin.*

Rp. Intestinoli N. 60 in tab.

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день после еды

Rp. Lienoli 30,0

DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой

Rp. Luteoglandoli 50,0

DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой

Rp. Luteoglandoli 0,05 II. t. d. N. 30 in tab. S. Ilo 1—2

таблетки 3 раза в день перед едой

Rp. Mammini 30,0

DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой

Rp. Mammini 0,3

D. t. d. N. 30 in tab.

S. По 1 таблетке 2—3—4 раза в день перед едой Rp.

Mammini 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день

- Rp. Orchicrini 50,0
DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой
- Rp. Orchicrini 1,0
D. t. d. N. 30 in amp.
S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день, всего 30—35 инъекций
- Rp. Orchicrini 0,5
D. t. d. N. 30 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день перед едой
- Rp. Ovarini 0,3
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3 раза в день перед едой
- Rp. Ovarini 30,0
DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой
- Rp. Ovarini 1,0
D. t. d. N. 12 in amp.
S. По 1 мл под кожу ежедневно в течение 15—20 дней (при гипофункции яичников, климактерических расстройствах)
- Rp. Pantocrini 30,0
DS. По 30—40 капель 2—3 раза в день перед едой
- Rp. Pantocrini 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл под кожу ежедневно в течение 25—30 дней
- Rp. Parathyreoidini 5,0 D. t. d. N. 12 in amp.
S. По 1—2 мл под кожу или в мышцу 1—2 раза в день (в зависимости от тяжести случая), сочетая с препаратами кальция
- Rp. Pylorini (Gastrocrini) 100,0 «
DS. По 1—2 чайных ложки 2—3 раза в день с жидкой пищей (молоко, кисель) Pituitrinum см. *Маточные средства*.
- Rp. Prolani 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл под кожу 2 раза в день
Из аптек пролан отпускается в двух ампулах: водной содержится порошок пролана, в другой — трикреоловая вода. Перед употреблением содержимое двух ампул смешивают в шприце
- Rp. Prostatini 0,3
D. t. d. N. 50 in tab.
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день перед едой
- Rp. Prostatini 50,0
DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой

- Rp. Prostatini 1,0
D. t. d. N. 12 in amp.
S. По 1 мл под кожу ежедневно в течение 30 дней
- Rp. Spermini 30,0
DS. По 30—40 капель 3 раза в день перед едой
- Rp. Spermini 1,0
D. t. d. N. 12 in amp.
S. По 1 мл под кожу ежедневно в течение 20—30 дней
- Rp. Synestrol 1,0 (10 000 ME) D. t. d. N. 10 in amp. S. По 1 ампуле ежедневно
- Rp. Thyreoidini 0,1
D. t. d. N. 20 in tab.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день перед едой
- Rp. Thyreoidini liquidi 10,0
DS. По 15—20 капель 3 раза в день перед едой
- Rp. Thyreoidini liquidi 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу 1 раз в день

Витаминные препараты

- Rp. Ac. ascorbinici 0,05 D. t. d. N. 20 in tab. S. По 1 таблетке 2 раза в день
- Rp. Sol. Ac. ascorbinici 5% 1,0 D. t. d. N. 10 in -amp. S. По 1—2 мл в мышцу или в вену
- Rp. Carotoli 1,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл под кожу (для профилактики и лечения А-гиповитаминоза и А-авитаминоза)
- Rp. Carotoni 5,0
DS. Наружное, в виде капель для глаз и носа несколько раз в день, в виде примочек (марлевые компрессы на десны и кожу)
- Rp. Vitadermi 50,0
DS. Мазь (при лечении ожогов всех трех степеней)
- Rp. 01. jecoris Aselli 200,0
DS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день перед едой (детям 3—6 лет)

- Rp. Sol. Thyamini (Vitamin Bi) 0,6% 1,0 D. t. d. N.
10 in amp.
S. По 1 мл под кожу, в мышцу или в вену ежедневно в течение 10 дней
- Rp. Thyamini 0,01
Sacchari 0,2
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошок 2 раза в день за 1 час до еды в течение 10 дней
- Rp. Riboflavini 0,005 Sacchari
0,2 M. f. p. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошок 3 раза в день (при себоррее, дерматитах, упорных конъюнктивитах и др.)
- Rp. Vitaminoli 10,0
DS. По 5 капель 1 раз в день в ложке теплого молока (детям 3—5 лет)
- Rp. Methynoni (Vitamin K) 0,005 01.
Persicorum sterilisati 1,0 D. t. d. N.
6 in amp.
S. По 0,5—1 мл в мышцу ежедневно в течение 2—3—5 дней
- Rp. Vicasoli 0,015
D. t. d. N. 6 in tab.
S. По 1 таблетке ежедневно 3—4 дня подряд
- Rp. Ac. nicotinici 0,05 Sacchari 0,2 •
M. f. pulv. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошок 3—4 раза в день в течение 2—3—4 недель
- Rp. Sol. Ac. nicotinici 1% 20,0 ♦
Sterilisetur!
DS. По 1 мл 2—3—4 раза в день под кожу или в вену в течение 2—3—4 недель

Белковые препараты (для протеинотерапии)

- Rp. Lactani 5,0
D. t. d. N. 5 in amp.
S. По 1 мл до 10 мл в мышцу, в зависимости от реакции и общего состояния организма, через 3—4 дня (при хронических воспалительных процессах)
- Rp. Lactoproteosani 1,0 D. t. d.
N. 6 in amp.
S. По 0,5—1 мл под кожу или в мышцу через 2—3 дня (при хронических, воспалительных процессах)

9

- Rp. Sol. Peptoni sterilisatae 5% 10,0
DS. До года — 0,5 мл, до 2 лет — 0,75 мл, до 3 лет — 1 мл, взрослым — 2—5 мл в мышцу; при аллергических заболеваниях как десенсибилизирующее средство (ревматизм, бронхиальная астма, крапивница и др.), а также при лечении острых и хронических поносов. В первый раз (взрослым) вводится 2—5 мл. Обычно всего делается не более 3—4 инъекций

Препараты для диагностики

- Rp. Barii sulfurici pro Roentgeno £0,0—100,0
DS. Для рентгеноскопии Rp.
- Bilitrasti 3,0
DS. На 1 прием с водой или с молоком (для рентгенографии желчного пузыря}
Максимальная контрастность желчного пузыря наблюдается через 13—15 часов после приема билитраста Rp. Sol. Fluorescein! solubilis 2% 5,0
DS. Накапывают на глаз несколько капель раствора (для обнаружения повреждений и инородных тел на роговице и конъюнктиве)
- Rp. Histamini 0,001 Aq.
destill. 1,0
D. t. d. N. 3 in amp.
S. По 0,25 мл в вену для определения скорости кровотока
- Rp. Jodognosti (Jodtetragnosti) 25,0
DS. Для рентгенографии желчных протоков и пузыря (холецистография) Rp. Jodolipoli (Lipojodoli) 10,0—20,0 D. t. d. N. 6 in amp.
S. Для бронхографии, метро- и сальпингографии Rp.
- Sergosini 20,0
DS. Для рентгеноскопии почечных лоханок, мочеточников и мочевого пузыря

Кровезаменители

- Rp. Sol. Natrii chlorati isotonicae sterilisatae £00,0 DS.
Для подкожных или внутривенных инъекций
- Rp. Sol. Ringer-Locke sterilisatae 500,0
DS. Применяется при тех же показаниях, как и физиологический раствор

aa-	ana	— поровну
Acet	Acetum	— уксус
Acid.	Acidum	— кислота
	ad chartam ceratam	— в восковой бумаге

ОБЪЯСНЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ В РЕЦЕПТАХ

ad chart. cer.	ad ollam	— в баночке
ad oil.	ad scatulam	— в коробочке
ad scat.	adde	— прибавь
add.	aequalis	— равный
aeq.	Aqua	— вода
Aq.	Aqua bidestillata	— дважды перегнанная вода
Aq. Mdest.	Aqua bulliens	— кипящая вода
Aq. bull.	Aqua destillata	— перегнанная вода
Aq. dest.	Aqua fontana	— ключевая вода
Aq. font.	Aqua sterillsata	— стерилизованная вода
Aq. stef.	Axungia porci	— свиное сало
Ax. pore.	Bolus	— шарик
Bol.	Butyrum	— масло
But.	cum	— с, вместе
c	Capsula amylacea	— облатка
Caps. arnyl.	Capsula gelatinosa	— желатиновая капсула
Caps. gel.	compositus, ta, turn	— сложный, ая, ое
сотр.	concentratus	— концентрированный
срнет.	consperge	— обсыпь
consp.	Cortex	— кора, корка
Cort.	da	— дай, отпусти
d.	detur	— пусть будет дано, отпущено
d.	dentur	— пусть будут даны, отпущены
	Decoctum	— отвар
	Da, Signa	— дай, обозначь
	Detur, Signetur	— пусть будет дано, обозначено
	Dentur tales doses	— пусть будет дано таких доз
	depuratus	— очищенный
	dilutus	— разведенный, разбавленный
	dimidium	— половина
	dispensetur	— развесь
	Divide in partes aequales	— раздели на равные части
	Eleosaccharum	— масло-сахар
	Emulsio	— эмульсия
	Emplastrum	— пластырь
	extende	— намажь
	extende supra linteum	— намажь на холст (полотно)
	Extractum	— экстракт
	Extractum fluidum	— жидкая вытяжка
	Extractum aquosum	— экстракт водяной
	Extractum sicum	— экстракт сухой
	fiat	— сделай
	fiat lege artis	— сделай по правилам науки
	Flores	— цветы
	flavus	— желтый
	Folium, Folia	— лист, листья
	Fructus	— плод(ы)
	grammum	— грамм
	Gelatina	— желатина
	gutta(s).	— капля, капель
f.		
l. 1.		
Flor.		
flav.		
Fol.		
Fruct.		
g.		
Gel.		
gtt.		

Herba	— трава
hora	— час
In ch. cer.	— в восковой бумаге
in ch. paraff.	— в парафиновой бумаге
inf.	— настой
inj. hypod.	— впрыскивание
Int. subcut.	— подкожное впрыскивание
l a.	— по правилам науки
Laor	— бутылка
lat	— шириной
Latitudo	— жилкость
lignor	— длиной
longitudine	— смешай
misce	— пилюльная масса
Massa nil	— миллиграмм
mg.	— миллилитр
ml	— смешай лай обозначь
MPS	— пусть будет дано обозначено
//Di	— смешай слепай
M l	— смешай слепай массу из ко-
M f. t. e. a	— топой будут скомбинированы
f	— смешай слепай порошок
formentur	— смешай. сделай овечку
M f n	— понемногу
M. f. supp.	— микстура
min	— слизь
Mixt	— номер
Muc.	— распыление
No Nr	— не повторяй
Neb	— не повторяй
Ne ren.	— покрой
Ne reiter	— масло
obd.	— банка
Oil.	— вино
Oil	— часть
Ov.	— порошок
P.	— осажженный
Pulv	— вес весом
net. nnt	— приготовленный
nd nond	— пилюли
naen	— порошок для присыпки
Pil	— зубной порошок
Pulv. adsn	— сколько угодно
Pulv. dent	— сколько достаточно
a l	— сколько хочешь
a s	— копень
a v	— свежий
Rad	— ошипенный
rec	— портони
rect	— копневище
reit	— розьми
Rhiz	— обозначь
Rn. R	— или
S.	— семя семена
s	— сигнатура
Sem	— сипоп
Sion	— пастроп
Sin	— пастропи
Sol	— обон
solv	— спит
Sn. Snec.	— винный спирт
Snir	— простой
Snir v	— половина
Snl	— пол печатку
SS	— тонкий, мелкий
sub. Sig	— тончайший, мельчайший
subt	— порошок
subts.	

t.	talis. tales	— такой, такие
Tab.	Tablettae	— таблетки
Tet., T-ra	Tinctura	— тинктура
Trit.	Trituratio	— растирание
trit	tritius	— растертый
Troch.	Troch. iscl	— лепешки
pro u. e.	pro usu externo	— для наружного применения
pro u. i.	pro usu inie. no	— для внутреннего применения
u. n.	usu nolo	— применение известно
Unō.	Unonentum	— мазь
ust	ustum	— жженный
Vit. от	Vitellum ovi	— яичный желток
Vitr.	Vitrum	— склянка, стекло

СТАНДАРТНЫЕ РЕЦЕПТЫ (ГОТОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)

Адонис с бромистым калием

Таблетки по 20 шт. в -стеклянной трубке. Заменяют одноименную микстуру.

Назначают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.

Состав:

Экстракта адониса сухого (соответствует 0,5 ч. травы адониса)

Бромистого калия 0,5

Асфеп]

Таблетки в упаковке по 6 шт. Применяют как жаропонижающее и болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Аспирин 0,25

Фенацетин 0,15

Аскофен

Таблетки в упаковке по 6 шт. Применяют при ревматических и невралгических болях как болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Аспирин 0,2

Фенацетин 0,2

Кофеин 0,04

Беварбон

Таблетки в упаковке по 6 шт. в стеклянной трубке. Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, изжоге и как болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Экстракт* листьев красавки густой 0,01

Бикарбоната натрия 0,3

Бесалол

Таблетки в упаковке по 6 шт. в стеклянной трубке. Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, изжоге и как болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Экстракта красавки густой 0,01

Салол 0,3

t.	talis, tales	— такой, такие
Tab.	Tabulettae	— таблетки
Tet., T-ra	Tinctura	— тинктура
Trit.	Trituratio	— растирание
trit	tritius	— растертый
Troch.	Troch iscl	— лепешки
pro u. e.	pro usu externo	— для наружного применения
pro u. i.	pro usu Inie.no	— для внутреннего применения
u. n	usu nolo	— применение известно
Unō.	Unonentum	— мазь
ust	ustum	— жженный
Vit. от	Vitellum ovi	— яичный желток
Vitr.	Vitrum	— склянка, стекло

СТАНДАРТНЫЕ РЕЦЕПТЫ (ГОТОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)

Адонис с бромистым калием

Таблетки по 20 шт. в -стеклянной трубке. Заменяют одноименную микстуру.

Назначают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.

Состав:

Экстракта адониса сухого (соответствует 0,5 ч. травы адониса)

Бромистого калия 0,5

Асфеп]

Таблетки в упаковке по 6 шт. Применяют как жаропонижающее и болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Аспирин 0,25

Фенацетин 0,15

Аскофен

Таблетки в упаковке по 6 шт. Применяют при ревматических и невралгических болях как болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Аспирин 0,2

Фенацетин 0,2

Кофеин 0,04

Беварбон

Таблетки в упаковке по 6 шт. в стеклянной трубке. Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, изжоге и как болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Экстракт* листьев красавки густой 0,01

Бикарбоната натрия 0,3

Бесалол

Таблетки в упаковке по 6 шт. в стеклянной трубке. Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, изжоге и как болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Экстракта красавки густой 0,01

Салол 0,3

Бетиол

Свечи по 10 шт. в коробке. Вес свечи 1,5—2 г. Применяют по 1—2 свечи как болеутоляющее средство при геморрое и простатите. Состав:

Экстракта листьев красавки густой 0,015

Ихтиола 0,2

Бутирола 1,3

Бикармипнт

Таблетки с запахом ментола. Применяют для полоскания горла при заболеваниях слизистой оболочки по 1—2 таблетки на полстакана теплой воды 2—3 раза в день. Выпускается в оригинальной упаковке по 25 шт. Состав:

Ментола 0,004 Хлористого
натрия 0,2 Борнонатриевой соли
0,4 Двууглекислого натрия 0,4

Вагилен

Вагинальные шарики, предупреждающие беременность. Выпускаются по 10 шт. в коробке. Состав:

Хинозола 0,003 Борной
кислоты 0,1 Бутирола 2,0

Вата «Дента»

Применяют при зубной боли.

Состав:

Ваты гигроскопической 1 ч.

Капель зубных «Дента» 6 ч.

*

Вата «Фарман»

Применяют при пасморке.

Состав:

Вата гигроскопическая, пропитанная раствором ментола с формалином, изготовленным по особой методике.

Веродон

Таблетки по 6 шт. в картонном футляре.

Применяют как болеутоляющее и жаропонижающее средство.

Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Пирамидона 0,3

Веронала 0,1

Гастрекс

Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях по 20—30 капель 3 раза в день.

Выпускается в стеклянных флаконах емкостью 15 мл.

Состав:

Жидкого экстракта из коробочек масличного мака 7 ч.

Настойки полыни 2 ч.

Настойки перечной мяты 1 ч.

Зубные капли «Дента»

Бесцветная, прозрачная густая жидкость характерного терпкого запаха.

Применяют при острой зубной боли, закладывая в дупло зуба смоченный каплями кусочек гигроскопической ваты. Выпускается по 50,0 в стеклянных флаконах. Состав:

Хлоралгидрата Г,0

Камфоры 1,0 Спирта

96° 1,0

Капсин

Жидкость желто-зеленого цвета, своеобразного запаха. Болеутоляющее средство наружное. При болях втирают в суставы.

Выпускается в стеклянных флаконах емкостью 10 мл.

Состав:

Этилового или метилового эфира салициловой кислоты 2 ч.

Настойки стручкового перца 4 ч.

Масла беленного 4 ч.

Кодтерпип

Таблетки в упаковке по 6 шт. Успокаивающее и отхаркивающее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Кодеина 0,01

Тершгагидрата 0,3

Бикарбоната натрия 0,3

*

Контрацептин

Шарики по 10 шт. в коробке весом каждый 1,8 г. Применяют как противозачаточное средство. Обладает антисептическими свойствами и способностью убивать сперматозоиды. Состав:

Хинозола 0,003

Борной кислоты 0,1

Жировой основы достаточное количество или

Молочной кислоты 0,15

Борной кислоты 0,25

Жировой основы 1,4

Офтальмол

Глазная мазь по 10,0. Применяют для лечения трахомы, фолликулярного катаракта и других заболеваний слизистой оболочки глаза.

Состав:

Ланолина 0,5 Вазелина 7,5
Лимонной кислоты 0,5
Едкого натра 0,35 Медного
купороса 1,15

Парегорик

Таблетки по 10 шт. в стеклянной трубке. Отхаркивающее средство, заменяющее опийно-бензойную настойку. Назначают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. Состав:

Экстракта опия 0,00375
Камфоры 0,015 Кислоты
бензойной 0,03 Масла
анисового 0,0075 Сахара
молочного 0,35

Пертусеип

Сиропообразная жидкость коричневого цвета, ароматного запаха и слабо соленого вкуса. Выпускается в стеклянных флаконах весом по 100 г. Сохраняют в темном месте. Применяют как отхаркивающее средство, смягчающее кашель при бронхитах и при коклюше в детской практике. Назначают детям по 1 чайной ложке и взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день. Состав: *

Экстракта тимьяна 12 ч.
Сиропа сахарного 82 ч.
Бромистого натрия 1 ч.
Спирта этилового 96° 5 ч.

Пирамеин

Таблетки по 6 шт. в картонном футляре. Болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 2 раза в день. Состав:

Кофеина 0,03
Пирамидона 0,3

Пираминаль

Таблетки в упаковке по 6 шт. Болеутоляющее и успокаивающее средство при невралгии и головной боли.

Назначают внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.

Состав:

Пирамидона 0,25
Люминала 0,02
Кофеина 0,03

Ппрафеп

Таблетки по 6 шт. в картонном футляре. Применяют при головных, а также при ревматических и невралгических болях. Назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Состав:

Пирамидона 0,25
Фенацетина 0,25

Салинимент

Жидкость зеленоватого цвета, характерного запаха. Выпускается в склянках по 50 мл. Наружное. Применяют для втирания как болеутоляющее средство при болях в суставах. Состав:

Метилового или этилового эфира салициловой кислоты 2 ч.
Масла беленного 6 ч. Хлороформа 2 ч.

Салицилово-цинковая паста по Лассару

Однородная, желтоватого цвета, густой консистенции масса. Содержит 2% салициловой кислоты и 25% окиси цинка. Применяют как антисептическое, местно обезболивающее и кератопластическое средство на воспаленные участки кожи и поверхностные раны.

Состав:

Салициловой кислоты в мельчайшем порошке 1,0
Окиси цинка 12,5 Крахмала 12,5 Желтого вазелина
24,0

Салофтол

Таблетки по 6 шт. в картонном футляре. Применяют при желудочно-кишечных заболеваниях как дезинфицирующее и болеутоляющее средство. Назначают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. Состав:

Экстракта красавки 0,01
Салола 0,3 Бензонафтола
0,3

СтрептоуроЕофепн

Таблетки по 10 шт. в картонном футляре. Применяют при простудах и гриппозных заболеваниях. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Уротропина 0,25
Стрептоцида 0,25
Кофеина 0,025

Таблетки азиатские

Дражированные таблетки белого цвета, внутри — буровато-желтого, выпускаются по 50 шт. в стеклянных флаконах. Назначают при острых и хронических анемиях.

Состав каждой таблетки:

Мышьяковистого ангидрида 0,001

Перца черного 0,25

Таблетки «Вло» (драже)

Дражированные таблетки белого цвета, внутри — зеленовато-бурого. Применяют при острых и хронических анемиях. Выпускаются по 50 шт. во флаконах. Назначают внутрь по 2 таблетки 3 раза в день. Содержание железа в одной таблетке 0,028.

Таблетки «Бло» с мышьяковистым ангидридом (драже)

Дражированные таблетки белого цвета, внутри — зеленовато-бурого. Применяют при острых и хронических анемиях. Выпускаются по 50 шт. во флаконах. Назначают внутрь по предписанию врача.

Состав каждой таблетки: Железа 0,028

Мышьяковистого ангидрида 0,001

Термопсис

Таблетки по 10 шт. в картонных футлярах. Применяют при кашле. Назначают по 1 таблетке 3—4 раза в день. Состав каждой таблетки:

Термопсиса в порошке 0,01

Опия в порошке 0,005

Бикарбоната натрия 0,25

Трипазол

Таблетки коричневого цвета, горьковато-сладкого вкуса, обладают запахам ментола и эвкалиптола, медленно растворяются во рту. Выпускаются по 20 шт. в картонных футлярах. Применяют при заболеваниях полости рта и горла (ангина, язвенный стоматит, гингивит, альвеолярная пиоррея, тонзиллит и др.). Профилактически назначают против дифтерии, гриппа, скарлатины и ангины. Сохраняют в прохладном и сухом месте. Состав:

Трипафлавина 0,003

Триборатгексамина 0,05

Ментола 0,0002

Эвкалиптола 0,00005

Сахара 0,42

Какао или какавеллы 0,09

Уросал

Таблетки в упаковке по 6 шт. Применяют при воспалительных заболеваниях желчного пузыря и мочевых путей. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Уротропина 0,3

Салола 0,3

Цефалгин

Жаропонижающее и болеутоляющее средство. Выпускается в виде таблеток. Назначают внутрь по 1 таблетке 2—3 раза в день. Состав:

Кофеина 0,03

Антифебрина 0,1

Аспирина 0,3

Цитрамон

В порошке по 1 г и в упаковке по 5 шт. Болеутоляющее средство. Назначают внутрь по одному порошку 1—2 раза в день. Состав:

Аспирина 0,24

Фенацетина 0,18

Кофеина 0,03

Какао в порошке 0,03

Лимонной кислоты 0,02

Ванилина 0,01

Сахара порошком 0,5

Цитросал

Таблетки в упаковке по 10 шт. Болеутоляющее, жаропонижающее и противоревматическое средство, назначают внутрь по 1 таблетке 1—2 раза в день. Состав:

Салипирина 0,3

Какао в порошке 0,03

Ванилина 0,01

Кофеина 0,03

Лимонной кислоты 0,02

Сахара 0,6

Эмульсия стрептоцида

Густая масса желтоватого цвета. Применяют как наружное средство при лечении ран. Сохраняют в хорошо закупоренном виде в затемненном месте. Состав:

Стрептоцида 5 ч.

Эмульсии рыбьего жира 95 ч.

Эмульсия сульфидина

Густая масса желтоватого или буроватого цвета. Применяют как наружное средство при лечении ран. Сохраняют в хорошо закупоренном виде в затемненном месте. Состав:

Сульфидина 5 ч.

Эмульсии рыбьего жира 95 ч.

Эмульсия стрептоцида и сульфидина

Густая масса желтоватого цвета. Применяют как наружное средство при лечении ран. Сохраняют в плотно закупоренных банках в затемненном месте. Состав:

Сульфидина 3 ч. Стрептоцида
белого 7 ч. Эмульсии рыбьего
жира 90 ч.

Стандартные аптечки

Домашняя аптечка содержит: 6 таблеток по 0,25 аспирина, 12 таблеток от головной боли, 20 таблеток от кашля, 12 таблеток урострептина, 25 таблеток пургена для взрослых, 20 таблеток двууглекислой соды по 0,5, 6 валериановых таблеток, 6 ландышевых таблеток, 10 таблеток перекиси водорода «Гидроперит», 5 таблеток свинцового уксуса, 20,0 цинковой мази, 25,0 борной кислоты, 50,0 английской соли; 2,5 марганцовокислого калия, 3,0 зубной ваты «Дента», 10 ампул нашатырного спирта по 1 мл, 1,5 сухого иода, 5 горчичников, 4 стерильных бинта, 25,0 гигроскопической ваты, 25,0 серой ваты, 2 листа компрессной бумаги, 1 катушку лейкопластыря, 1 глазную пипетку, 1 термометр.

Колхозная аптечка содержит: 20 таблеток от головной боли, 40 таблеток от кашля, 20 таблеток урострептина, 20 таблеток кальцекса, 30 шт. или 30,0 желудочных болеутоляющих таблеток или капель, 30,0 сердечных капель (настойка валерианы и ландыша или настойка ландыша и пустырника), 25,0 борной кислоты, 50 таблеток двууглекислой соды по 0,5, 100,0 английской или глауберовой соли, 2,5 марганцовокислого калия, 20,0 цинковой мази, 50,0 вазелина, 10,0 зубных капель (или 2,0 ваты «Дента»), 20 ампул нашатырного спирта по 1 мл, 30,0 настойки иода (или 2 ампулы сухого иода по 15,0), 5 стерильных бинтов, 10 простых бинтов, 100,0 гигроскопической ваты, 1 резиновый (или матерчатый) жгут, 1 термометр, 1 стаканчик для приема лекарств.

Карманная аптечка содержит: 6 желудочных болеутоляющих таблеток, 6 таблеток от головной боли, 6 валериановых таблеток, 10 таблеток от кашля, 6 таблеток двууглекислой соды по 0,5, 1 ампулу настойки иода, 1 ампулу нашатырного спирта, 1,0 зубной ваты, 2,0 кровоостанавливающей ваты, 3,0 гигроскопической ваты, 4 катушки лейкопластыря, 1 стерильный бинт.

Аптечка для новорожденных содержит: 20,0 борной кислоты, 2 ампулы сухого иода, 20,0 вазелина, 10,0 детской присыпки, 100,0 гигроскопической ваты, 0,5 м клеенки подкладной, 2 бинта, 1 максимальный термометр, 1 водяной термометр, 2 глазные пипетки, 2 резиновые соски, 2 м марли, 20,0 двууглекислой соды.

Оборы — чай

Сбор ветрогонный №1 (Species carminativa) Мята перечная листья 2 ч. Фенхеля плоды 1 ч.
Валерианы корень 2 ч.

Две чайных ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, как чай. После охлаждения принимать утром и вечером по V_2 стакана в теплом виде.

Сбор ветрогонный № 2 (Species carminativa)

Ромашки цветы 2 ч. Мята
листья 2 ч. Фенхеля
семена 1 ч. Тмина семена
1 ч. Валерианы корень 2 ч.

Две чайных ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, как чай. После охлаждения принимать утром и вечером по одному стакану в теплом виде.

Сбор ветрогонный № 3 (Species carminativa)

Ромашки цветы 2 ч.
Душицы трава 2 ч'.

Две чайных ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю и принимать утром и вечером по одному стакану в теплом виде.

Сбор горький (аппетитный) № 1 (Species amara)

Полынь трава 1 ч. Айра корневище 1 ч. Трилистника листья 1 ч. ■
Тмина семена 1 ч. Столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, кипятить 20 минут, процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день за 20 минут до еды по 1 столовой ложке.

Сбор горький (аппетитный) № 2 (Species amara)

Полынь трава 2 ч.
Тысячелистника трава 2 ч.
Одуванчика корень 1 ч.

Столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать за 20 минут до еды по 1 столовой ложке.

Сбор горький (аппетитный) № 3 (Species amara)

Полынь трава 4 ч.
Тысячелистника трава 1 ч.

Столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать за 20 минут до еды по 1 столовой ложке.

Сбор грудной №1 (Species pectoralis)

Алтейный корень 2 ч. Мать-мачехи листья 2 ч. Душицы
трава 1 ч.

Столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать в теплом виде по $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана 3 раза в день как отхаркивающее средство.

Сбор грудной №2 (Species pectoralis)

Мать-мачехи листья 4 ч.
Подорожника ланцетолистого листья 3 ч.
Солодковый корень 3 ч.

Столловую ложку сбора облить стаканом кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать в теплом виде по $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ стакана 3 раза в день как отхаркивающее средство.

Сбор грудной №3 (Species pectoralis)

Шалфея листья 1 ч. Аписа
плоды 1 ч. Алтайский корень 2
ч. Солодковый корень 2 ч.
Сосновые почки 1 ч.

Столловую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по $\frac{1}{4}$ стакана 3 раза в день как отхаркивающее средство.

Сбор грудной №4 (Species pectoralis)

Алтейный корень 2 ч.
Солодковый корень 2 ч.
Укропа плоды 1 ч.

Столловую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по $\frac{1}{4}$ стакана через 3 часа как отхаркивающее средство.

Сбор отхаркивающий (Species pectorans)

Мыльный корень туркестанский измельченный 4 ч.
Солодковый корень измельченный 1 ч.

1 чайную ложку сбора заварить в стакане кипятка, настаивать полчаса, процедить и выпить в течение дня в 3—4 приема. Сбор
желудочный №1 (Species stomachica)

Крушины кора 3 ч. *
Мяты перечной листья 2 ч.
Крапивы листья 3 ч.
Аира корневище 1 ч.

Валерианы корень 1 ч. Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по $\frac{1}{2}$ стакана утром и вечером.

Сбор желудочный №2 (Species stomachica)

Крушины кора 2 ч.
Аниса плоды 2 ч.
Тысячелистника трава 1 ч.
Горчичное семя 2 ч.

Солодковый корень 3 ч. Две чайных ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по

Сбор желудочный №3 (Species stomachica)

Черники ягоды 2 ч. Лапчатки
корневище 1 ч. Бессмертника
цветы 1 ч. Шалфея листья 3 ч.
Тмина семена 1 ч.

Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить по охлаждению через марлю и принимать 3 раза в день по $\frac{1}{2}$ стакана за 15—10 минут до еды.

Сбор желчегонный (Species cholagoga)

Бессмертника цветы 4 ч.
Трилистника листья 3 ч. Мяты
перечной листья 2 ч.
Кориандра плоды 1 ч.

Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю и принимать по $\frac{1}{2}$ стакана 3 раза в день за 20 минут до еды при желтухе и воспалении желчных путей.

Сбор мочегонный №1 (Species diuretica)

Толокнянки листья 3 ч. Василька цветы 1 ч.
Солодковый корень 1 ч.

Столловую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 минут, после чего процедить через марлю и принимать по указанию врача.

Сбор мочегонный №2 (Species diuretica)

Толокнянки листья 4 ч.
Солодковый корень 1 ч.
Можжевельные ягоды 1 ч.

Столловую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю и принимать 3—4 раза в день по столовой ложке за 10 минут до еды.

Сбор мочегонный №3 (Species diuretica)-

Можжевельные ягоды 2 ч.
Хвоща полевого трава 2 ч.
Пырея корневище 1 ч.

Столловую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю и принимать по указанию врача.

Сбор мочегонный №4 (Species diuretica)

Можжевельные ягоды 1 ч.
Дягиля корень 1 ч. Василька
цветы 1 ч.

Столловую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю, принимать по указанию врача.

Сбор мочегонный №5 (Species diuretica)

Березы листья 1 ч.

Хвоща полевого трава 1 ч.

Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, остудить, процедить через марлю и выпить в 3 приема в течение дня.

Сбор мягчительный для припарок (Species emolliens)

Ромашки цветы 1 ч.

Донника трава 1 ч.

Равные по весу массы ромашки и донника заварить кипятком прикладывая горячую массу, завернутую в ткань, к больному месту.

Сбор поливитаминный №1 (Species polyvitaminica)

Шиповника плоды 1 ч. Черной смородины ягоды 1 ч. Заваривают и пьют, как чай.

Сбор поливитаминный №2 (Species polyvitaminica)

Шиповника плоды 5 ч. Рябины ягоды 5 ч. Заваривают и пьют, как чай.

Сбор для полоскания горла №1 (Species ad gargarismam)

Дуба кора 2 ч.

Липы цветы 1 ч.

Две столовых ложки заварить в стакане остудить и полоскать несколько раз в день.

Сбор для полоскания горла (Species ad gargarismam)

Ромашки цветы 3 ч.

Липы цветы 2 ч.

Две столовых ложки заварить в стакане кипятка, как чай, остудить и полоскать несколько раз в день.

Сбор потогонный №1 (Species diaphoretica)

Липы цветы 1 ч.

Малины ягоды 1 ч.

Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 5 минут и пить настой горячим по стакану 2 раза в день при ревматизме и гриппозных состояниях.

Сбор потогонный №2 (Species diaphoretica)

Малины ягоды 2 ч. Мать-мачехи листья 2 ч. Душицы трава 1 ч.



~~~~~

III

Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 10 минут, процедить через марлю и пить отвар-настой горячим по стакану 2 раза в день при ревматизме и гриппозных состояниях.

Сбор потогонный №3 (Species diaphoretica)

Ивы кора 2 ч. Мать-мачехи листья 2 ч. Душицы трава 1 ч. Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 10 минут, процедить через марлю и пить настой горячим по стакану 2 раза в день при ревматизме и гриппозных состояниях. Сбор

противогеморройный (Species antihaemor-rhoidalis)

Александрийского листа 1 ч.

Тысячелистника трава 1 ч.

Крушины кора 1 ч.

Кориандра плоды 1 ч.

Солодковый корень 1 ч. Столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и, остудив, пить на ночь по  $V_2$  стакана.

Сбор противопоносный (вяжущий) №1 (Species ad stringeus)

Черемухи плоды 3 ч. Черники ягоды 2 ч. Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать, остудив, 3 раза в день по  $V^*—V_2$  стакана.

Сбор противопоносный (вяжущий) №2 (Species ad stringeus)

Ольхи серой шишки 2 ч.

Змеевика корневище 1 ч.

Две чайных ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, как чай, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать в течение дня 3—4 раза.

Сбор пгзотивопоноспый (вяжущий) №3 (Species ad stringeus)

Лапчатки корневище 1 ч.

Змеевика корневище 4 ч.

Две чайных ложки заварить в стакане кипящей воды, настаивать полчаса, процедить и выпить в течение дня в 3—4 приема.

Сбор противопоносный (вяжущий) №4 (Species ad stringeus)

Змеевика корневище 1 ч.

Кровохлебки корневище 1 ч.

Две чайных ложки заварить в стакане кипящей воды, настаивать полчаса, процедить и выпить в течение дня в 3—4 приема.

Сбор противопоносный (вяжущий) №5 (Species ad stringeus)

Конского щавеля корень 1 ч.  
Змеевика корневище 1 ч.

Две чайных ложки заварить в стакане кипятка, настаивать полчаса, процедить и выпить в течение дня в 3—4 приема. Сбор слабительный №1 (Species laxans)

Крушины кора 3 ч. Крапивы  
листья 2 ч. Тысячелистника  
травы 1 ч.

Две столовых ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю, принимать по  $V_2 - \frac{3}{4}$  стакана на ночь.

Сбор слабительный №2 (Species laxans)

Александрийского листа 3 ч.  
Крушины кора 2 ч. Жостера  
ягоды 2 ч. Аниса плоды 1 ч.  
Солодкового корня 1 ч.

Две столовых ложки сбора заварить в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по  $V_2 - \frac{3}{4}$  стакана на ночь.

Сбор слабительный №3 (Species laxans)

Крушины кора 8 ч.  
Солодковый корень 1 ч.  
Кориандра плоды 1 ч.

Столовую ложку сбора заварить в стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать по  $\frac{x}{2} - \frac{0}{2}$  стакана на ночь.

Сбор слабительный №4 (Species laxans)

Крушины кора 6 ч.  
Тысячелистника травы 2 ч.  
Крапивы листья 2 ч.

Столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 20 минут, процедить через марлю и принимать по  $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$  стакана на ночь.

Сбор успокоительный №1 (Species sedativa)

Мяты перечной листья 2 ч.  
Трилистника листья 2 ч.  
Валерианы корень 1 ч.  
Хмеля соцветия 1 ч.

Две столовых ложки сбора заварить 2 стаканами кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить через марлю и принимать 2 раза

в день утром и на ночь  $\frac{1}{2}$  стакана при состоянии нервного возбуждения и раздражительности.

Почечный чай, листья (Folium Orthosiphoni). Почечный чай — Orthosiphon stamineus — тропическое растение из семейства губоцветных, выращенное в Сухуми. Содержит гликозид-ортосифонин. Применяют настой из листьев 1 : 200 на суточный прием. Предложен Всесоюзным научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и испытан в терапевтической клинике санитарно-гигиенического факультета I Московского ордена Ленина медицинского института как мочегонное средство на больных с нефрозами и нефритами, а также при сердечной недостаточности. Наилучшее мочегонное действие отмечалось у декомпенсированных сердечных больных, которым до применения почечного чая назначали сердечные средства, не дававшие мочегонного эффекта.

Разрешен к выпуску фармакологическим комитетом Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения СССР (протокол № 8 от 1 апреля 1960 г.).

Аборт 417  
 — задержавшийся 418.  
 — начинающийся 417  
 — неполный 417  
 — поздний 417

## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

— полный 417  
 — профилактика 418  
 — ранний 417  
 — трубный 423  
 — угрожающий 417  
 Абсцессы 325  
 — аппендикулярный 325  
 — заглоточный боковой 495  
 — легкого 9  
 — мозга 326  
 — носовой перегородки 502  
 — околоминдаликовый 496  
 — перитонзиллярный 496  
 — печени 326  
 — поддиафрагмальный 327  
 — уха 495  
 Абуладзе 'метод выделения плаценты 456  
 Авитаминоз А 517  
 — В<sub>1</sub> 12  
 — В<sub>2</sub> 13  
 — С 128  
 — К 13  
 — РР 90  
 Авитаминозы, психозы 253  
 Агастрическая анемия 22  
 Агранулоцитоз 14 Аддисонова  
 болезнь 15 Аденоиды 496  
 Аденома 537 Адинамия 254 Аднексит 467  
 Адонизид, отравление 682 Адонилен,  
 отравление 682 Адонис, отравление 682  
 Адреналин, отравление 664 Адский камень,  
 отравление 683 Адсорбирующие средства,  
 рецепты  
 773 Азота закись, отравление 672 Азотная  
 кислота, отравление 675 Азотнокислос,  
 серебро, антисептические свойства 331

Азотнокислос серебро, отравление 683  
 Акация желтая, отравление 664  
 Аконитин, отравление 668  
 Аконит, отравление 664  
 Акрихин, отравление 664

■ — психозы 240  
 Акририд (риванол), отравление 664  
 Акромегалия 16  
 Актиномикоз 327  
 Акушерка, правила выписки рецг. тов 703  
 Акушерство 417  
 Алейкия алиментарно-токсическая 18  
 Алиментарная дистрофия 16  
 — психозы 253  
 Алиментарно-токсическая алейкия  
 18 Алкоголь, отравление 691  
 — амиловый, отравление 691  
 — винный, отравление 691  
 — древесный, отравление 691  
 — трибромэтиловый, наркотическое  
 свойство 365  
 Алкоголизм хронический 235  
 Алкогольные психозы 235 Алкогольный  
 галлюциноз 235 Альбомуцин, рецепты 741  
 Альвеолярная пиорея 581 Амезия 143  
 Амезная дизентерия 143 Аменорея 468  
 Амевтивный синдром 265 Амидалин,  
 отравление 690 Амилнитрит, отравление  
 665 Амиловый спирт, отравление 691  
 Амилоидный нефроз 87 Амидаль-натрий,  
 отравление 670 Аммиак, отравление 682  
 Амнестический (корсаковский) синдром  
 265 Амфодоитоз 581 АнаОазин, отравление  
 665 Аналгин, отравление 660 Анаэробные  
 инфекции 142, 340 Ангина катарральная 497  
 — лакунарная 497  
 — Людовика 498

Ангина септическая 18  
 — фолликулярная 498  
 — язвенно-пленчатая 498  
 Ангини инфекционные 497  
 Ангидроз 328 Ангидролит 126  
 Аневризма 329  
 — аорты 25  
 Анемия 21  
 — агастрическая 22  
 — апластическая 22  
 — бирмеровская 23  
 — гемолитическая 23  
 — злокачественная 23  
 — новорожденных врожденная 277  
 — пернициозная 23  
 — психозы 254  
 Анестезия в глазной практике 517  
 — местная 329  
 — спинномозговая 330  
 Анилин (химические краски, ка-  
 рандаши и пр.), отравление 665  
 Анилиновые краски, антисептические  
 свойства 331 Аппиоз 330 Антибиотки  
 732 Антипирин, отравление 666  
 Антирабическая вакцина 754  
 Антисептика в акушерстве 419 Антисептики  
 для кишечника, рецепты 790  
 — желчных путей, рецепты 792  
 — легких, рецепты 800  
 — мочевых путей, рецепты 797  
 Антисептический материал 331  
 Антисептические средства 173, 331  
 Антифебрин, отравление 665 Антифриз,  
 отравление 666  
 — психозы 240  
 Анурия 24, 332, 362  
 Аорта, аневризма 25  
 — воспаление 25  
 — мешчатое расширение 25 Аортит  
 25  
 — сифилитический 25 Апато-абулический  
 синдром 265 Апластическая анемия 22  
 Апоморфин, отравление 666 Апоневроз  
 ладонный, склероз 353 Аппендикулярный  
 абсцесс 326 Аппендицит острый 26, 332  
 — хронический 334  
 Аптечка для новорожденных 838  
 — домашняя 838 ■ —  
 карманная 838  
 — колхозная 838 Арахноидит  
 209 Арколин, отравление 681  
 Аритмия 26  
 — мерцательная 26 Арренал,  
 отравление 666 Артериальное  
 кровоотечение 355 Артерии мелкие,  
 склероз 86  
 — прижатие (остановка кровоотечения)  
 355  
 — расширение 329  
 Артериолы склероз 86  
 Артериосклероз 31

Артериосклероз головного мозга 238  
 Артрит бруцеллезный 104  
 — деформирующий 102  
 — дизентерийный 104  
 — гонорройный 56, 104  
 — мочеислый 102  
 — обезображивающий 102  
 — подагрический 102  
 — сифилитический 104  
 — туберкулезный 104 Асептика  
 в акушерстве 419 Аскаридоз 53  
 — у детей 282 Аспирин, отравление 688  
 Астенический синдром 265 Астеническое  
 состояние 241 Астено-адинамический  
 синдром 265 Астма бронхиальная 27  
 — У детей 276  
 — сердечная 30  
 Асфиксия 362  
 — новорожденных 421  
 — белая 421  
 — бледная 421 — ■  
 — синяя 421  
 — плода 420  
 — внутриутробная 420  
 — профилактика по А. П. Ни  
 колаеву 421  
 — травматически 403  
 Асцит 336  
 Ателектаз легкого у новорожденных 277  
 Атерома 335 Атеросклероз 31 Атоксил,  
 отравление 666 Атония желудка 110  
 Атофан, отравление 667 Атрепия влагалища  
 470  
 — заднего прохода и прямой кишки  
 277  
 Атропин, отравление 667 -г- —  
 психозы 240 Атрофия кожи 537  
 — зрительного нерва 518  
 — печени желтая 48  
 — острая 48 Аура см. *Эпилепсия*  
 Аутогемотерапия 604 Ахилия желудка  
 33 Ацезал, отравление 688  
 Ацетилхолин, отравление 681  
 Ацетилхолинхлорид 681 Аэрозоли  
 пеницилина 735  
 — стрептомицина 73 5  
 Аэрон, отравление 667

Базедова болезнь 34 Бактериофаг  
 дизентерийный 758 Балаит 537  
 Баланопостит 537 Банга болезнь 133  
 Банки Бира 604 — сухие 604  
 Барбамил, отравление 670 Барбитураты,  
 отравление, психозы 240

Барбитураты,противопо-  
казания при  
применении 275 Барий и его соединения,  
отравление  
667  
— едкий, отравление 667  
— хлористый, отравление 667 Бедро,  
врожденный вывих 338 Безбелковые отеки  
16 Безвременник осенний, отравление  
667 Белая горячка 236  
Белена, отравление 667 Бели  
470  
Белильная известь, отравление 699  
Белковые препараты, рецепты 826  
Белладонна, отравление 667 Белокровие 72  
Бельма роговицы 535 Белый мышьяк,  
отравление 681 Бензин, отравление 668  
Бензол, отравление 668 Беременность  
внематочная 423  
— — брюшная 423  
— — трубная 423  
— — яичниковая 423  
— многоплодная 426 Беременные, острая  
дистрофия печени 428  
— рвота неукротимая 453  
— «скрытые отеки» 425  
— токсикоз 428  
— — психозы 254  
Бери-бери 12  
Бертолетова соль, отравление 668  
Бесплодие женщин 472 Бессонница 210  
Бетанафтол, отравление 682 Бешенство 136  
— психозы 242  
Бигумаль, рецепты 765  
Биокулярная повязка глазная 521  
Биопсия 605  
Бледная немочь 126  
Бледная поганка, отравление 686  
Бленнорея глаз 523  
Блефарит сухой 517  
— язвенный 518  
Близорукость 518  
Блокада сердца 26  
Блуждающая (подвижная, опущен-  
ная) почка 109  
Болезни желудочно-кишечного тракта,  
психозы 253  
— обмена, рецепты лекарственных  
средств 818  
— печени, психозы 253 ■—  
почек, психозы 254  
— сердца, психозы 253  
Болезнь Аддисона 15  
— Базедова 34  
— Банга 138  
— Боткина 35 ■—  
бронзовая 15  
— Васильева-Вейля 154  
— Верльгофа 119  
— Гейне-Медина 210  
— гипертоническая 49  
— Дюринга 537

Болезнь Литтля 225  
— папатачи 161  
— Педжета 408  
— Реклингаузена 409 Болеутоляющие  
средства, рецепты  
780  
Воли поясничные при гинекологических  
заболеваниях 489  
Болиголов, отравление 684  
Болотная лихорадка 158  
Боль головная 211  
— запломбированного зуба 582  
Больные психические, культурное  
обслуживание 268  
— — организация лечебной помощи 267  
— — патронаж 269  
— — трудовая терапия 268 Борец,  
отравление 668 Борная кислота,  
отравление 669 Бородавки 538  
— обыкновенные 538 ■—  
старческие 538  
— юношеские плоские 538 Бородавчатый  
туберкулез кожи 554 Боткина болезнь 35  
Ботулизм 138 Бродильная диспепсия 105  
Брома соли, отравление 669 Бром,  
отравление 669  
— — психозы 240 Бромная вода,  
отравление 669 Бромурал, отравление  
670 Бронзовая болезнь 15  
Бронхаденит туберкулезный 120  
Бронхиальная астма 27  
— — у детей 276 Бронхи,  
расширение 40 Бронхит  
астматический 27  
— острый 38  
— — у детей 278  
— хронический 39  
Бронхопневмония 100  
— мелкоочаговая катарральная у  
детей 294 \*  
Еронхоэктазы 40  
— у детей 296  
Бруцеллез 138  
— психозы 243 Бруцеллезная вакцина  
752 Бруцеллезный артрит 104 Брюшина,  
воспаление 3 80 Брюшная полость,  
повреждения закрытые 381  
Брюшной тиф 138 ■—  
— психозы 243  
Еужирование 605 Бурсит  
острый 335  
— хронический 335

Вагинит 473  
— трихомонадный 474  
Вакцины 749  
Ванны (а) водяные 606  
— горчичные 606  
— горячие 6015  
— для промежности 606

Ванны(а)  
индифферентные 606  
— крахмальные 607  
— лекарственные 605  
— марганцовокися 606  
— ножные 606  
— с отрубями 607  
— прохладные 606  
— соленные 607  
— теплые 606  
— хвойные 607  
— холодные 606 Варикозные  
расширения вен 335 Варикоцеле 336  
Васильева-Вейля болезнь 154 Веки  
верхние, опущение 531  
— — воспаление краев сухое 517 ■—  
выворот 520 Венепункция 607  
Венерическая болезнь четвертая  
580 Венерические болезни 561  
— — борьба 576  
— — контроль за лечением 576  
— — профилактика врожденного  
сифилиса 578  
— — учет 576  
Венесекция 608  
Вератрин, отравление 669  
Верльгофа болезнь.119  
Веронал, отравление 670  
Веселящий газ, отравление 672  
Веснушки 538  
Вех ядовитый, отравление 684  
Взрывные газы, отравление 670  
Винный спирт, отравление 691  
Викасол, рецепты 826 Витамин А,  
рецепты 825  
— В, рецепты 825  
— В1, рецепты 826  
— С, рецепты 826  
— D, рецепты 825  
— E, рецепты 826  
— K, рецепты 826  
— PP, рецепты 826 Витаминные  
препараты, рецепты  
825  
Витаминол, рецепты 826  
Витамины, нормы суточной потребности  
человека 312  
— содержание в пищевых продук-  
тах 315  
Влагалище, выпадение 482  
— опущение 48?  
Власоглав 54 Вливания  
608  
— внутривенные 608  
— подкожные 609 Внематочная  
беременность, разрыв  
трубы 423 Вода горьких миндалей,  
отравление  
690 Водобоязнь 136 Водяница  
541 Водянка беременных 424  
— головного мозга 210  
— желточного пузыря 336  
— живота 336

Водянка оболочек яичка  
337  
— почечных лоханок 344  
Водяной газ, отравление 670  
Возбудители важнейших эпидеми-  
ческих заболеваний и их жизне-  
способность во внешней среде  
186  
Возбуждающие средства, рецепты  
783 Возбуждение в коре головного мозга  
263  
— вызванное большими потерями крови  
273  
— галлюцинаторно-параноидное 272  
— депрессивное, тревожно-депрессивное  
271  
— кататоническое 271  
— маниакальное 272  
— острое 269  
— отдельные виды 270  
— при инфекционных и токсических  
психозах 270  
— при эпилепсии 274  
— — травмах мозга 273  
— противопоказание при применении  
средств, купирующих возбуждение 275  
— процессы (подвижность, инертность,  
уравновешенность) 263  
— психогенного характера 273  
— психомоторное 241  
Возвратный тиф 141  
Волосатость 539 Волчанка  
554  
— красная 539 Волчья  
пасть 279  
Воспаление головного мозга 176  
— — гортани 505  
— грудных желез у новорожденных 284  
— зрительного нерва 518  
— клетчатки около прямой кишки 376  
— кожи 540  
— краев век сухое 517  
— легких, психозы 243  
— миндалин 514  
— мочевого пузыря 412  
— нервов 221  
— оболочек головного мозга 160 —  
околопочечной клетчатки 376  
— мозговых оболочек 216  
— околосердечной сумки 91  
— паутинной оболочки мозга\* 209  
— передних рогов спинного мозга 227  
— придатка яичка 413  
— придаточных пазух носа острое 499  
— — — хроническое 499  
— радужной оболочки 519  
— почечных лоханок у детей 293  
— сетчатки 520  
— слезного мешка 520  
— слизистой оболочки глаз 528  
— сосцевидного отростка 506  
— среднего уха, острое 501  
— — — гнойное хроническое 502



Дистрофия печени острая при беременности 213  
 Дисульфид, отравление 693  
 Диуретин, отравление 678  
 Дифтерия 152  
 — гортани 504  
 Дихлорамин, отравление 699  
 Дизтапослеоперационная 348  
 Древесный спирт, отравление 691  
 Дурман, отравление 667  
 Дюпоитрена контрактура 353  
 Дюринга дерматит герпетиформный (болезнь) 537  
 Дыхание искусственное 616  
 Дыхательные пути, инородные тела 350  
 Едкий барий, отравление 667  
 — натр, отравление 703 <\*\*\*  
 Едкое кали, отравление 703  
 Жавелева вода, отравление 699  
 Жаропонижающие средства, рецепты 787  
 Жгут, наложение 355  
 Железа(ы) околюшная, воспаление 377  
 — предстательная, воспаление 384  
 — гипертрофия 384  
 — потовые, воспаление 344  
 Желудочное содержимое, методика взятия и исследования 613, 646  
 Желтая острая дистрофия печени 428  
 Желтуха 58  
 — беременных 428  
 — гемолитическая 23  
 — инфекционная 35, 48, 154  
 — катарральная 35, 48  
 — механическая 58  
 — новорожденных симптоматическая 288  
 — физиологическая 288  
 — спирохетная 35, 48  
 Желудок, ахилия 33  
 — катарр 44  
 — кровотечение 70 —  
 невроты 80  
 — опущение 46  
 — острое воспаление 42, 47  
 — промывание 634  
 — расширение 110  
 Желудочно-кишечные средства, рецепты 788  
 Желчегонные средства, рецепты 792  
 Желчнокаменная болезнь 60  
 Желчные протоки, воспаление 126  
 Желчный проток, закупорка 349  
 — пузырь, водянка 336  
 — — воспаление 126  
 — — прободение 385  
 Живот, вздутие газами 75  
 — водянка 336  
 — острый 372  
 Заворот кишок 349  
 Задержание яйца 349

Задержка мочи 361  
 — лохий (послеродовых выделений) 428  
 — плаценты 429  
 Задний проход, трещины 404  
 Заикание 212  
 Закись азота, отравление 672  
 — применение для газового нар коза 364  
 Закрутка 356  
 Закупорка общего желчного протока 349  
 Замерзание 655  
 Занавеска (глазная повязка) 521  
 Занозы 350  
 Занос кровяной 417  
 — мясистый 417  
 — пузырьный 430  
 Запах изо рта 592  
 Запоры 61, 288  
 Заразительный моллюск 547  
 Застойный сосок 524  
 Засыпанные землей (оказание помощи) 655  
 Заушница 178, 377  
 Заячья губа 279  
 Зеленъ французская, отравление 081  
 Землей засыпанные (оказание помощи) 655  
 Зимовник осенний семена, отравление 677  
 Злокачественное малокровие 23  
 Змеиный яд, отравление 673  
 Зоб узловатый токсический см. *Базедова болезнь*  
 Зоб эндемический 63  
 Золотой дождь, отравление 664  
 Зонд толстый 613  
 — тонкий 613  
 Зрительный нерв, неврит 518  
 — — атрофия 518  
 Зубная боль 582, 587, 590  
 Зубной камень 583  
 Зубы, заболевания 581  
 — прорезывание 589 «  
 — экстракция 598  
 Зубные капли «Дента» 833  
 Зуд кожный 541  
 Известь белильная, отравление 699  
 — негашеная, отравление 673  
 Икота 212  
 Инвагинация 594  
 Инородные тела 350  
 — — гортани и бронхов 503  
 — — дыхательных путей 350  
 — — мочевого пузыря 351  
 — — мягких тканей 3"50  
 — — носа 503  
 — — пищевода 351  
 — — уха 504  
 Инсектициды, рецепты 806  
 Имбецильность 249  
 Импетиго заразное 549  
 — простое 549  
 Инкубационный период инфекционных болезней, сроки 180  
 Инсулин, отравление 673

Инсульт 212, 238  
 Интубация 615  
 Инфаркт легкого 63  
 — миокарда 64  
 Инфекционная желтуха 154  
 Инфекционные болезни, возбудители, жизнеспособность во внешней среде 186  
 — — способы собирания материала для лабораторного исследования 182  
 — — сроки изоляции 189  
 — — сроки инкубации 180  
 Инфекция анаэробная, 340  
 — входные ворота 190  
 — источники и пути распространения 190  
 — пути выделения инфекционного начала 190  
 Инфекционные психозы 242  
 — — в связи с хроническими инфекциями 244  
 Инъекции 609  
 Йод, отравление 673  
 Йодная настойка, антисептические свойства 331  
 — — отравление 673  
 Йодоформ, отравление 674  
 Ипекакуана, отравление 674  
 Ипохондрический синдром 266  
 Искривление носовой перегородки 504  
 Искусственное дыхание 616  
 Исследование глаз 525  
 — желудочного содержимого 646  
 — кала 649  
 — крови 636  
 — мокроты 651  
 — мочи 642  
 — налетов 653  
 — отделяемого из половых органов 654  
 Истерия 244  
 Ихтиоз 542  
 Ишиас 214  
 Казацкий можжевельник, ягоды, отравление 680  
 Какодиловый натрий, отравление 674  
 Кала-азар 156  
 Кал, методы исследования 649  
 Календарь для определения сроков родового и послеродового отпуска 465  
 Кали едкое, отравление 703  
 Калийная селитра, отравление 689  
 Каломель, отравление 693  
 Калорийность пищевых продуктов 313  
 Камни желчных путей и печени 60  
 — мочевого пузыря 352  
 — почек 108  
 Камфора, отравление 674  
 Канатик семенной, расширение вен 336  
 Кантаридин, отравление 702

Капсин, рецепты 833  
 Карболовая кислота, антисептические свойства 331  
 ■ — отравление 697  
 Карбохолин, отравление 681  
 Карбункул 352  
 Кардиосклероз 66  
 Карлес зуба 584  
 Катаракта 525  
 Катарр желудка 44  
 Катарральная пневмония 100  
 Кататонический синдром 266  
 Катетеризация мочевого пузыря 618  
 Каузалгия 214  
 Кератит паренхиматозный 526  
 Керато-конъюнктивит скрофулез-ный (туберкулезный аллергический) j26  
 Керосин, отравление 668  
 Кесарево сечение 460  
 — — по методу Гусакова 460  
 Кетгут 360  
 Киноварь, отравление 693  
 Кислоты, отравление 67 5  
 — и ферменты, рецепты 788  
 Киста яичника ретенционная 480  
 Кисты шеи 398  
 Кишечник, атония 61  
 — невроты 81  
 ■ — непроходимость 366 -V  
 прободение *объ* Кишечное кровотечение 132  
 Кишка, внедрение 349  
 Кишки заворот 349  
 — острое воспаление 47  
 — толстые, воспаление слизистой оболочки 67  
 — туберкулез 120  
 Клещевина, семена и жмыхи, отравление 687  
 Клизмы 618  
 Климактерические расстройства 480  
 Клоачный газ, отравление 690  
 Кодеин, отравление 680  
 Кодтерпин, рецепты 833  
 Кожа, атрофия 537  
 — воспаление 540  
 — зуд 541  
 — раздражающие средства, рецепты 811  
 Кожевниковская эпилепсия 234  
 Кожная форма лейшманиоза 157  
 Кожный рак 552  
 Кокаин, отравление 676  
 Коклюш 154  
 Коклюшная вакцина 753  
 Колбасный яд, отравление 686  
 Коленный сустав, деформации 347  
 — — разрыв менисков 387  
 Колика печеночная 60  
 Колит острый 67  
 — хронический 69  
 — — У детей 389  
 Коллапс 111  
 Колларгол, отравление 698  
 Колоцинта плоды, отравление 677  
 Колоцинтин, отравление 677  
 Колхицин, отравление 677

Колпит 473  
 Кома диабетическая 56  
 — гипогликемическая 56  
 — уремическая 84, 85, 86  
 Коммоционные психозы 254  
 Компресс согревающий 622  
 — спиртовой 622 Конвазид,  
 отравление 682 Конваллен,  
 отравление 682 Кондилломы  
 острые 481  
 — остроконечные см. *Бородавки* Кониин,  
 отравление 684 Конская стопа 353  
 Контактный остеомиелит 585 Контрактура  
 Дюпоитрена 353  
 — суставов 353 Контрацептин, рецепты  
 833 Контузионные психозы 254 Контузия  
 мозга 231 Конъюнктивит дифтерийный 528  
 — инфекционный 528  
 — острый 528  
 — фолликулярный 528  
 — хронический 529 Коразол, отравление  
 677 Кордиамин, отравление 678 Коронарная  
 недостаточность 66,  
 117 Коронаросклероз 66, 117  
 Коронаротромбоз 64  
 Корсаковский психоз 237  
 — (амнестический) синдром 265  
 Корь 155  
 Косоглазие 529  
 Косолапость 354  
 Костей родовые повреждения (у но-  
 вороджденных) 458 Кости, воспаление 370  
 — туберкулез 405 Кофе, отравление  
 678 Кофеин, отравление 678  
 Крапивница 612 Красавка, отравление  
 667 Краски медные, отравление 678  
 — свинцовые, отравление 689  
 Краснуха 156  
 Креде метод, выдавливание плаценты 456  
 Крезолы, отравление 697 Креозот,  
 отравление 697 Креолин, отравление 697  
 -Крепкая водка, отравление 678 Кретинизм  
 63 Кривошея 354 Крипторхизм 355  
 Кровавая рвота 70  
 — — новорожденных 389  
 Кровезаменители 827  
 Кровоизлияния внутричерепные у  
 новорожденных 389  
 — в полость плевры 70  
 — под конъюнктиву 530  
 Кровоостанавливающие средства 793  
 Кровотечение(я) 355  
 — артериальное 355  
 — венозное 350  
 — желудочное (острое) 70  
 — капиллярное 356  
 Кровотечение(я) кишечные 132  
 — климактерические 480  
 — легочные 70  
 — маточные 483  
 — носовое 504  
 — окончательная остановка 356  
 — паренхиматозные 356 Кровопотери,  
 возбуждение 273 Кровоточивость 47  
 Кровохарканье 70  
 Кровь, исследование 636  
 Кровяная опухоль 342  
 — — носовой перегородки 502  
 Кровяной занос 417  
 Круп тортапный 504 Крупозная пневмония  
 96 Крыловидная плева 530 Кукольник,  
 отравление 6 85 Кукольные  
 зерна, отравление 685 Куриная слепота 517  
 Лабиринтит гнойный 505  
 Лабораторная техника 636  
 Лабораторные исследования, способы  
 собирания материала от больных 182  
 Лавровишневая вода, отравление 690  
 Ландыш, отравление 682  
 Ларингит острый 505  
 — — у детей 290  
 — хронический 505 Ларинготрахит 505  
 Левомецетип, рецепты 743 Легкие,  
 воспаление, психозы 243  
 — инфаркт 63  
 — крупозное воспаление 96  
 — отек 89  
 — туберкулез 120 Легочное сердце 71  
 Легочно-сердечный синдром 71 Лед 622  
 Лекарства, нерациональные прописи  
 727 Лекарственные смеси, несовмести-  
 мость 727 \*  
 — средства новые 765  
 Лейкемия 72  
 — лимфатическая 74  
 — миелоидная 72  
 — острая 72  
 Лейкоз 72  
 — острый 73 Лейкопения 73 Лейкоплакия  
 592 Лейкоцитарная формула-640 Лейкоцитоз  
 74 » Лейкоциты крови, методы подсчета  
 637 Лейшманиоз 156  
 — внутренних органов 157  
 — кожи 157  
 Ленточные глисты у взрослых 55  
 — — у детей 283  
 Лечебные сыворотки 743  
 Лизол, антисептические свойства 332  
 — отравление 697

Лизозим, рецепты 742 Лимфаденит 358  
 Лимфангоит 357 Лимфатическая лейкемия  
 74 Лимфатические сосуды, воспаление  
 357\*  
 — узлы, воспаление 358  
 — туберкулез 404  
 Лимфогранулематоз 74  
 — паховый (четвертая венерическая  
 болезнь) 580 Литтля болезнь 225  
 Липоидный нефроз 87 Липома 358  
 Лихорадка болотная-, 158  
 — папатачи 161 Лицевой нерв,  
 паралич 215 Лишай 543  
 — красный плоский 543  
 — опоясывающий 543 ■—  
 отрубевидный 544  
 — пузырьковый 544  
 — разноцветный 544  
 — розовый 544  
 — стригущий 545  
 — чешуйчатый (псориаз) 546  
 Лобелии, отравление 679  
 Лобелия, отравление 679  
 Лобная пазуха, воспаление см. *Воспаление  
 придаточных пазух* ■носа  
 Ложный круп 290  
 Люкит, задержка 428  
 Люголя раствор, отравление 673  
 Люмбаго 76, 215  
 Люминал, отравление 670  
 Лямблиоз 126, 131  
 Ляпис, отравление 683  
 Магнезия сернокислая, противопоказания  
 при применении 275 Маллал, отравление  
 67 Малокровие 21  
 — злокачественное 23  
 — острое 358  
 Мальтийская лихорадка см. *Бруцеллез*  
 Малярия 158  
 — психозы 243  
 — трехдневная 158  
 — тропическая 158  
 — четырехдневная 158 Маниакально-  
 депрессивный психоз  
 246 Маниакальный синдром 246  
 Марганцовокислый калий, антисеп-  
 тические свойства 332  
 — — отравление 679  
 Мастит 481  
 — хронический 359 Мастоидит  
 острый 506 Материал для швов 359  
 Матка, воспаление мышц 484  
 — — слизистой оболочки 492  
 — выпадение 482  
 — миома 485  
 — опущение 482  
 Матка разрыв 452  
 — рак 489  
 — ущемление 492  
 — фибромиома 485  
 — шейки разрывы 453  
 — — эрозия 493 Маточные  
 кровотечения 483  
 — рожки, отравление 692 Медиастинит  
 360 Медиал, отравление 670 Меди  
 сульфат, отравление 694 Медные краски,  
 отравление 694 Медный купорос,  
 отравление 679 Медь и ее соединения,  
 отравление  
 694  
 Мезаорит 25  
 Меккеля дивертикул 347 Мелена 3  
 89 Менингит 216  
 — гнойный 216  
 — серозный 216  
 — хронический 45  
 — туберкулезный 217  
 ■— эпидемический цереброспинальный  
 160  
 Менингококковая вакцина 753  
 Меноррагия см. Маточные кровотечения  
 Менструации болезненные 478  
 — отсутствие 468  
 Меньера симптомокомплекс (болезнь) 506  
 Меркузал, отравление 693  
 Местная анестезия, средства (ре-  
 цепты) 795  
 Метакопниотические бронхиты  
 Метеоризм 75  
 Метиловый спирт, отравление 691  
 — спирт, отравление 691  
 ■— эфир салициловой кислоты,  
 отравление 688  
 Метод Абуладзе 456  
 — Гусакова 460  
 — Кред-з 4 56 Метрит 484  
 Метроэндометрит 492  
 Миалгия 76  
 Миарсенол, отравление 683  
 Мигрень 217 Микроспория 547  
 Микроцефалия 218 Микседема 76  
 Миндаль горький, отравление 690  
 Минеральные вещества, содержание  
 в пищевых продуктах 320  
 Милиарный туберкулез 120  
 Миозит 76  
 Миокарда инфаркт 64  
 Миокардиодистрофия 77  
 Миокардиопатия 78  
 Миокардиосклероз 66  
 Миокардиосклероз 66 Миокардит  
 острый 78  
 — хронический 79  
 Миома матки 485  
 Миопатия 218  
 Мизлит инфекционный 219

- Миелоидная лейкемия 72  
 Можжевеловое эфирное масло, отравление 68  
 Можжевельника ягоды, отравление 680  
 Можжевельник казацкий, отравление 680  
 Мозг головной, абсцесс 326  
 — — — артериосклероз 238  
 — — — возбуждение и торможение 263  
 — — — повреждение 360  
 — — — сдавление 360  
 — — — сотрясение 360  
 — — — травмы 231  
 — — — ушиб 361  
 — — — костный, воспаление 370  
 — — — паразиты 224  
 — — — сдавление 360  
 — — — сотрясение 231  
 — — — спинной, травмы 232  
 — — — ушиб 231  
 Мозговой удар 212  
 Мокрота, методика исследования 651  
 Моллюск паразитический 547  
 Молния, поражение 656  
 Молочай, отравление 703  
 Молочница 290  
 Монокулярная повязка 521  
 Моносепп, отравление 693  
 Морская болезнь 79  
 Морской лук, отравление 682  
 Морфин, отравление 680  
 — — — противопоказания при применении 275  
 — — — соли, отравление 680  
 Морфинизм 248  
 Москитная лихорадка 161  
 Моча, задержка 361  
 — — — методика исследования 642  
 — — — недержание 362, 486  
 — — — неудержание 486  
 — — — полное прекращение выделения 382  
 Мочевой пузырь, воспаление 412  
 — — — инородные тела 351  
 — — — камни 352  
 — — — промывание 623  
 Мочегонные средства, рецепты 796  
 Мочеиспускание, расстройства 361  
 Мочеиспускательный канал, отсутствие верхней стенки 413  
 — — — нижней стенки 413  
 Мочекишечный артрит 102  
 Муравьиная кислота, отравление, 681  
 Мускарин, отравление 681  
 Мухомор, отравление 681  
 Мушки (шпанские) 623  
 Мыло зеленое, отравление 703  
 Мытье рук при операциях 623  
 Мышьяк, отравление 681  
 — — — белый, отравление 681  
 Мышьяковая кислота, отравление 681  
 Мышьяковистая кислота, отравление, 681-  
 ■ Мышьяковистый водород, отравление 681  
 Мягкий шанкр 563  
 Мясистый занос 417  
 Мясной яд, отравление 686  
 Навязчивости синдром см. Психическая  
 Нагрубание физиологическое грудных желез у новорожденных 284  
 Надкостница, воспаление 380  
 Налеты из глотки, методы исследования 653  
 Наперстянка, отравление 682  
 Наркоз 362  
 — — — внутривенный 364  
 — — — газовый 364  
 — — — нарколовый 365  
 — — — противопоказания к применению 364  
 — — — прямокишечный 365  
 — — — эфирное оглушение 365  
 Наркозан, отравление 682  
 Наркотические средства 369  
 Наркомания см. Морфинизм  
 Нарцеин, отравление 680  
 Нарыв загноившийся 495  
 Насморк атрофический 507  
 ■ вазомоторный (сосудодвигательный) 507  
 — — — зловонный (озена) 508  
 — — — неврогенный (рефлекторный) 507  
 — — — острый 508  
 — — — хронический 509  
 Натр едкий, отравление 703  
 Натрий какодиловокислый, отравление 681  
 — — — салициловокислый, отравление 682  
 Нафталин, отравление 682  
 Нашатырный спирт, отравление 682  
 Невралгия межреберных нервов 219  
 — — — плечевого сплетения 219  
 — — — седалищного нерва 214  
 — — — тройничного нерва 219  
 Неврастенические симптомокомплексы 220  
 Неврастения см. также Неврозы  
 220  
 Неврит зрительного нерва 518  
 — — — лицевого нерва 215  
 — — — локтевого нерва 221  
 — — — лучевого нерва 221  
 — — — седалищного нерва 214  
 — — — слухового нерва 509  
 — — — срединного нерва 221  
 Невриты 221 - . Невроз желудка 80  
 — — — кишечника 81  
 — — — пищевода 81  
 — — — сердечно-сосудистый 82  
 Неврозы внутренних органов 80  
 Неврома 366  
 Негашеная известь, отравление 633,  
 705  
 Недержание мочи 486

- Недержание мочи ночное 222  
 Недоношенные дети 291  
 Некронефроз 83  
 Непроходимость кишечника 366  
 Нерациональные прописи лекарств 727  
 Нервная система, типы по И. П. Павлову 263  
 Нервные процессы, сила и слабость по И. П. Павлову 263  
 Несовместимость лекарственных смесей 727  
 Неувеен, рецепты 771  
 Неукротимая рвота беременных 453  
 Нефрит очаговый 85  
 — — — острый 84  
 — — — хронический 85  
 Нефроангиосклероз артерий мелких 86  
 — — — артериол 86  
 — — — почечек 86  
 Нефроз 87  
 — — — липоидный 87  
 — — — амилоидный 87  
 Нефропатия беременных 431  
 Нефроптоз 109  
 Нефросклероз артерий мелких 86  
 — — — артериол 86  
 — — — почечек 86  
 Никотин, отравление 683  
 Никотиновая кислота (витамин PP), рецепты 826  
 Нитрат серебра, отравление 683  
 Нитрит натрия, отравление 683  
 Нитробензол, отравление 665  
 Нитроглицерин, отравление 683  
 Новарсенол, отравление 683  
 Новокаин, отравление 676  
 Ноготь выросший 367  
 Нома 367, 592  
 Нормы выхода готовых изделий в пищевых предприятиях 322  
 Нос, повреждение придаточных пазух 512  
 — — — рак 510  
 — — — саркома 510  
 Носовая перегородка, абсцесс 502  
 — — — гематома 502  
 Ночное недержание мочи 222  
 Ночные страхи детей 223  
 Обвитие пуповины 431  
 Обволакивающие средства, рецепты 815  
 \* Обезболивание 329  
 — — — родов 432  
 — — — техника применения медикаментозных средств 433  
 — — — психопрофилактический метод 446  
 Обеззараживание (стерилизация) 624  
 Обертывание 625  
 Обмен веществ, лекарственные средства, рецепты 818  
 Обморок 111, 656  
 Оглушенности синдром 267  
 Одонтогенный остеомиелит 585  
 Ожирение 88  
 Ожоги 367  
 — — — глаз лучистой энергией 530  
 Озена 508  
 Ознобление 547  
 Окись свинца, отравление 684  
 — — — углерода, отравление 696  
 — — — психозы 240  
 Олигофрения 249  
 Омег болотный, отравление 684  
 — — — водяной, отравление 684  
 — — — пятнистый, отравление 684  
 — — — ядовитый, отравление 684  
 Омертвление легкого 9  
 Омнопон, отравление 680  
 Онихия 373  
 Онихомикоз 547  
 Опий, отравление 685  
 Определение срока отпуска до родов и после родов 465  
 Определенности 291,  
 548  
 Опухоли головного мозга 223  
 — — — гортани 510  
 — — — злокачественные 513  
 — — — носа 510  
 — — — спинного мозга 224  
 — — — в матке, перекручивание ножки 488  
 — — — гигантоклеточные 409  
 — — — кровяные 347  
 Опушение верхнего века 531  
 — — — влагалитца 482  
 — — — матки 482  
 — — — почки 109  
 Органопрепараты, рецепты 825  
 Орхит 370  
 Оспа ветряная 101  
 — — — натуральная 162  
 — — — психозы 243  
 Оспенный детрит 757  
 Остеодистрофии фиброзные 403  
 Остеомиелит 370  
 — — — контактный 585  
 — — — одонтогенный 585  
 — — — острый 585  
 — — — психозы 254  
 — — — хронический 371  
 — — — челюсти 585  
 Остит фиброзный 371  
 — — — генерализованный 409  
 Острицы у детей 283  
 Острый живот 372  
 Острые инфекционные психозы  
 • 242  
 Отеки безбелковые 16  
 — — — голодные 16  
 — — — легких 89  
 Отечная болезнь 16  
 Отморозение 372  
 Отит 501  
 Отосклероз 510  
 Отравления острые, первая помощь (материал расположен в алфавитном порядке) 660  
 — — — применение, лекарственных веществ, рецепты 728  
 Отхаркивающие средства, рецепты 798



Офтальмия симпатическая 531  
 — электрическая (световая) 531  
 Офтальмол, рецепты 834  
 Очки (определение) 531  
 Падающая болезнь 233  
 Панариций 373  
 — кожный 374  
 — костный 374  
 ■ — подкожный 374  
 — подногтевой 374  
 — суставной 375 Панкреатит  
 375 Панофтальмит 521 Пантопон,  
 отравление 680  
 — противопоказания при приме-  
 нении 275  
 Пантоцид, отравление 699  
 Паппатачи лихорадка 161  
 Папоротник, отравление 685  
 — экстракт, отравление 685  
 Папуло-некротический туберкулоид  
 554 Парааминосалициловая кислота  
 (ПАСК), рецепты 768  
 Паразиты кишечные 53  
 — мозга 224  
 Параличи детские 225  
 \* — гортанных мышц 511  
 — периферические (родовые) 226  
 Паралич дрожательный 225  
 Параметрит 487  
 Паранефрит 376 Парапроктит 376  
 Паратиф А и В, 163 Паратифозные  
 заболевания 163 Парафимоз 409  
 Параклорфенол, отравление 685 Парегорик,  
 рецепты 628 Паренхиматозный кератит 526  
 Пародонтоз 531  
 Пароксизмальная тахикардия 89  
 Паротит гнойный 37  
 — эпидемический 178  
 Парша 548  
 ПАСК 768  
 «Патологическая инертность» по И. П.  
 Павлову 258  
 Паутинная оболочка головного мозга,  
 воспаление 209  
 Паховый лимфогрануломатоз 580  
 Педжета болезнь 408  
 Пеллагра 90  
 Пеллоидин, рецепты 772  
 Пеллоидоэтиллат, рецепты 770  
 Пельвеоперитонит 487  
 Пендинская язва 157  
 Пенициллин 733  
 (— дозировки 735  
 £- побочное действие и осложнения при  
 применении 736  
 — показания при хирургических  
 заболеваниях 737  
 Пентавакцина 757  
 Пептическая язва 415  
 Первая помощь при острых отравлениях  
 (материал расположен в алфавитном  
 порядке) 664

Первая помощь при острых отравлениях  
 неопознанными ядами 663  
 Переливание крови 626  
 Переломы 377  
 — ключицы 378  
 — — плечевой и бедренной кости у  
 новорожденных 292  
 — костей черепа 379  
 — ребер 379  
 — трубчатых костей 377  
 — челюсти 585  
 Перепись водородо, антисептические  
 свойства 332 Перикардит 91  
 Перидонит 587 Перистит 380 Перитонит  
 380 Перихондрит гортанных хрящей  
 511 Перичементит 587  
 Пернициозная анемия 23  
 Пертуссип, рецепты 834 Перчатка  
 628 Песь 549 Печень, абсцесс 326  
 — атрофия желтая 48  
 — острая 48  
 — дистрофия желтая 48  
 — острая 35, 48  
 — сифилис 116  
 — цирроз 127  
 — эхинококк 414  
 Печеночная колика 60  
 Пиемические процессы, психозы 243  
 Пикриновая кислота, отравление  
 675 Пикротоксин, отравление 685  
 Пилокарпин, отравление 685  
 Пилороспазм 293 Пилоростеноз 292  
 Пиодермия 549 Пионефроз 381  
 Пиопневмоторакс 101 Пирамеин,  
 рецепты 83^ Пирамидон, отравление  
 666 Пираминаль, рецепты 834  
 Пирафен, рецепты 835 Пирогаллол,  
 отравление 697 Пирокатехин,  
 отравление 697 Питание  
 искусственное 629  
 — физиологические нормы в СС  
 309  
 — хроническое расстройство 303  
 Пиурия у детей 293  
 Пищевые токсикоинфекции 42, 47,  
 164, 686  
 — продукты, нормы выхода готовых  
 изделий 322  
 — — содержание витаминов 315  
 — — минеральных веществ 320  
 — — поваренной соли 321  
 ■ — — химический состав и калорийность  
 313  
 Пищеварение, хроническое расстройство  
 303  
 Пищевод, воспаление 92  
 — дивертикул 347

Пищевод, инородные тела 351  
 — невроз 81  
 — ожог 369  
 — прободение 385 -  
 спазм 81  
 — сужение 92, 400  
 Пиэлит 92  
 — у детей 293  
 Пиявки 629  
 Плазмодид, отравление 686 Нлатифиллин,  
 отравление 667 Плацентарный полип 417  
 Плацента, выделение по методу Абуладзе  
 456  
 — — — — — Креде 456  
 — задержка 429  
 — нормально расположенная, пре-  
 ждевременная отслойка 445  
 — предлежащие 430  
 Плевра, кровоизлияние в полость 70  
 — скопление воздуха 101  
 Плеврит выпотной 93  
 — гнойный 95  
 — — у детей 293  
 — серозный 93  
 — сухой 95  
 — экссудативный 93  
 Плеввропневмония 96  
 Плевшиность 550  
 Пневмококк 96  
 Пневмония 100  
 — аспирационная 100  
 — вирусная 100  
 — долевая крупноочаговая у детей 296  
 — катаральная 100  
 — крупозная 90  
 — — у детей 296  
 — межочечная у детей 297  
 — мелкоочечная у детей 294  
 — очаговая 100  
 — хроническая у детей 296  
 Пневмосклероз 101  
 — у детей 296  
 Пневмоторакс 101  
 Поваренная соль, содержание в пищевых  
 продуктах 321 Повешение 657 Поворот  
 плода 434  
 — — на ножку 435  
 — — — — — при головном предле-  
 жании 436  
 — наружный при поперечном по-  
 ложении 435  
 Повреждение (я) носа и его придаточных  
 пазух 512  
 — глаз механические 532  
 — гортани 511  
 — уха 512  
 Повязки 630  
 Поганка бледная, отравление 686  
 Подагра 102 Подвижная почка 109  
 Поддиафрагмальный абсцесс 327  
 Подофиллин, отравление 677 Подсвязочное  
 острое воспаление гортани 505  
 Позвоночник, повреждения 382

Позвоночник, туберкулез 406 Полиартрит  
 деформирующий 102  
 — ревматический острый 103  
 — обезображивающий 102  
 — ревматический хронический 104  
 — инфекционный 104  
 Поливакцина 757  
 Полимиэлит острый 227  
 Полиневрит 226 Полип(ы)  
 носа 512  
 — плацентарный 417 ■ —  
 тела матки 488  
 — уха 513  
 Положение плода косое 436  
 — — поперечное 436  
 Пороки сердца 106  
 — — врожденные 106 Помутнение  
 хрусталика 525 Понижение питания у  
 детей 279 Поносы 105  
 Поражение молнией 656  
 — электрическим током 660  
 Послед, ручное отделение и выделе-  
 ние 429  
 Послеоперационный период 382  
 Послеродовой период 438  
 Послеродовые психозы 254  
 — язвы 464 Потап,  
 отравление 689 Потливость  
 550 Потница 551 Потогонные  
 средства 860 Почесуха 551  
 Почечная колика 108  
 — лоханка, водянка 344  
 — — — — — воспаление слизистой оболоч-  
 ки 92  
 Почечнокаменная болезнь 108 Почка  
 беременных 431  
 — блуждающая 109, 383  
 — опухоль 369  
 — опущенная 109  
 — первично сморщенная 86  
 — повреждения 483  
 — подвижная 109, 383  
 — смещенная 383  
 — сулемовая 83  
 — туберкулез 407 Поясничные боли 489  
 Предлежащие детского места 439  
 — плаценты 439  
 — боковые 439  
 — краевые 439  
 — — центральные 439  
 — плода головное неправильное 441  
 — лицевое 442  
 — лобное 442  
 — переднеголовное 442  
 — тазовое 443  
 — — ручное пособие по методу Цо-  
 вьянова 444  
 Преждевременная отслойка пор.  
 мално расположенного детского места 445  
 Преждевременные роды 445 Прекращение  
 дыхания у плода  
 420 Препараты для диагностики 827

Презклампсия 461  
 Прижигающие средства 800  
 Пробные завтраки 633  
 Прогрессивный паралич 250  
 — лечение прививкой малярии 250  
 Прозерин, отравление 697 Проказа 551  
 Прокол живота 633  
 — плевры 633 Пролежень 385  
 Промежности разрыв 453  
 Промывание желудка 634  
 — мочевого пузыря 63 4  
 Пронаркон, отравление 670  
 Прорезывание зубов 589  
 Простатит 384 Прострел 255  
 Протаргол, отравление 698  
 Противоанемические средства, рецепты 801  
 Противоботулиническая сыворотка 746  
 Противогеморроидальные средства, рецепты 803  
 Противоглистныe средства, рецепты 803  
 Противогонорейные средства, рецепты 802  
 Противодизентерийная сыворотка 747  
 Противодифтерийная сыворотка 747  
 Противокашлевые средства, рецепты 799  
 Противокислотные средства, рецепты 788  
 Противомаларийные средства, рецепты 804  
 Противоневралгические средства, рецепты 780  
 Противопаразитарные средства, рецепты 806  
 Противопневмококковая сыворотка 748  
 Противоподагрические средства, рецепты 807  
 Противопонозные средства, рецепты 791  
 Противорвотные средства, рецепты 807  
 Противосифилитические средства, рецепты 808  
 Противоскарлатинозная антитоксическая сыворотка 748  
 Противоспазматические средства, рецепты 809  
 Противостафилококковая антитоксическая сыворотка 749  
 Противостолбнячная сыворотка 748  
 Противотощнотные средства, рецепты 807  
 Противоядия, рецепты 811  
 Протовератрин, отравление 669  
 Прямая кишка выпадение 339  
 Псевдартроз 386  
 Психастения 250  
 Психиатрические больницы, ле.-чебно-охранительный режим 267

Психиатрический патронаж 269 Психические болезни, скорая помощь 269 Психогенные реакции 252  
 Психоз корсаковский 237 Психозы инфекционные 242 ■ — коммоционные 254  
 — контузионные 254  
 — при ранении черепа 254  
 — реактивные 252  
 — «симптоматические» 253  
 — травматические 254  
 Психоневрологические диспансеры 269  
 Психопрофилактический метод обезболивания родов 446  
 Психотерапия 267  
 Псориаз 546  
 Птоманы, отравление 686  
 Пузырный занос 430  
 Пузырчатка 551  
 Пульпа зуба, гангрена 590  
 Пульпит 590  
 — острый 590  
 — хронический 590 Пульс 109  
 Прострел 76 Пуловина, выпадение 425  
 — обвитие ребенка 431  
 Пупок, заболевания 298  
 — флегмона 298  
 — язва 298 Пупочный грибок 298 Пятна родимые 552 Пятнистый омел, отравление 684

Радикулит пояснично-крестцовый 228  
 Разрезы гнойников 386  
 Раздражающие кожу средства, рецепты 811  
 Разрыв влагалища 453  
 — промежности 453  
 — шейки матки 453 «  
 Разрывы менисков коленного сустава 387  
 — сухожилий 387 Рак 388  
 — водяной 367  
 — гортани 513  
 — грудной железы 389  
 — желудка 389  
 — кожный 552  
 ■ — глубокий 552  
 — плоский 552  
 — поверхностный 552  
 — матки 489  
 — молочной железы 389  
 — носа 510  
 — пищевода 390  
 — психозы 254  
 — прямой кишки 391  
 — толстых кишок 391  
 — шейки матки 489  
 — языка 392  
 Ракитник, отравление 664 Раневое истощение 394

Рана гнойная 394 Ранение(я) брюшной полости 394  
 — внечерепные, психозы 254  
 — глаза прободные 538  
 — грудной клетки 395  
 — черепа и мозга 396 Раны 392  
 Растяжение связок сустава 396  
 Расширение вен (варикозное) 335  
 — желудка НО  
 Рахит 298 Рвота ПО  
 — беременных 453  
 — неукротимая 453  
 — кровавая 70  
 Рвотные средства, рецепты 812 Рвотный корень, отравление 687  
 — орех, отравление 692  
 Реактивные психозы 252 Реакция психогенная 252 Ревматизм 103, 111  
 — суставной, психозы 243 Ревматический острый полиартрит 103  
 — хронический полиартрит 104  
 Ревмокардит 111  
 Резорцин, отравление 697 Реклингауза болезнь 409 Ректон, отравление 670  
 Рецепты, объяснение сокращений 828  
 — правила прописывания врачами 702  
 Риванол, антисептическое свойство 332  
 — отравление 687  
 Риносклерома 514  
 Рицин, отравление 687  
 Роговая оболочка глаза, язва 535  
 — — — ползучая 535  
 Родимые пятна 552  
 Родинки 552  
 Родовая деятельность, слабость 457  
 Родовой акт, периоды 454  
 — период изгнания 4 54 —, —  
 — последовый 454  
 — — — раскрытия 454  
 Родовые параличи 226  
 — схватки судорожные 458 Роды нормальные 454  
 — — ведение 455  
 — — метод Абуладзе 456  
 — — механизм ^55  
 — преждевременные 445  
 — профилактика 416  
 — профилактика травматизма 458  
 — психопрофилактический метод обезболивания 446  
 Рожа 165  
 — головы, психозы 243  
 Рот, уход за полостью 597  
 Ртуть, отравление 693  
 Рыбный пл, отравление 686  
 Рыбья чешуя 542

Сабина, отравление 688  
 Салицимент, рецепты 835

0

Салипирин, отравление 688 Сальварсан, отравление 683 Салициловая кислота, отравление 688  
 Салицилово-цинковая паста Лассара, рецепты 835 Салофтол, рецепты 835 Сантонин, отравление 688 Сап 165 Саркома 396  
 — носа 510  
 Сахарин, отравление 688 Сахарное мочеизнурение 56 Сахарный диабет 56  
 Сборы лекарственных трав (чай) 838 Светильный газ, отравление 670  
 Свинец, отравление 689 Свинца окись, отравление 689 Свинцовые (й) белила, отравление 689  
 — сахар, отравление 689  
 — уксус, отравление 689 Свищи 397, 491  
 — гнойные 397  
 — желудочные 397  
 — желчные 397  
 — заднего прохода 397  
 — каловые 397  
 — мочевого пузыря 397  
 — мочеточники: -е 397  
 — слюнные 398  
 ■ уретральные 397  
 ■ мочевые 397  
 Сбросы 552  
 — сухая 553  
 Селитра, отравление 689  
 Сепсис новорожденных 300  
 — отогенный 513  
 Сепсисы 398  
 Септикопиемия 398  
 Септицемические процессы, психозы 243  
 Септицемия 398  
 Сердечная астма 30  
 Сердечная мышца, острое воспаление 78 Сердечно-сосудистые неврозы 82  
 Сердечно-сосудистая недостаточность острая 111  
 — — — хроническая 113  
 Сердечные средства, рецепты 812  
 Сердечный приступ 30, 64, 82, 117 Сердце, блокада 26  
 — декомпенсация 111  
 — легочное 71  
 — пороки 106  
 Серебро азотнокислое, отравление 689 Серебряные соли, отравление 689  
 Серная кислота, отравление 689  
 Сернистая кислота, отравление 689  
 Сернистый ангидрид, отравление 689  
 Сернистый газ, отравление 689 Серные пробки 514 Сероводород, отравление 690  
 Сероуглерод, отравление 690 Серы двуокись, отравление 689

Сетчатка глаза, глиома 522  
 Сибирская язва 166  
 Сивушное масло, отравление 690  
 Сидероз 96  
 Сикоз 553  
 Силикоз 96  
 Симпатическое воспаление глаз  
 538 Симпатическая офтальмия 538  
 Симптом Аршиль-Робертсона 230  
 Синдром(ы) аментивный 265  
 — амнестический (корсаковский) 265  
 — апато-абулический 265  
 — астено-адинамический 265  
 — галлюцинаторно-параноидный 265  
 — гебедренический 265  
 — делириозный 265  
 — депрессивный 266  
 — ипохондрический 266  
 — кататонический 266  
 — оглушенности 267  
 — эйфорически-атакисический 241  
 — ■ при психических заболеваниях  
 265 Синильная кислота, отравление 690  
 Синтомицин, рецепты 771 Сирингомизлия  
 229 Сифилит бугорковый 566 Сифилис 565  
 — аорты 25  
 — детей, лечение пенициллином 578  
 — нервной системы 229  
 — печени 116 Сифилитический  
 артрит 104  
 — гепатит 116 Скарлатина 168  
 Скарлатинозная комбинированная  
 вакцина 754 Скинпидар,  
 отравление 691 Склеродермия 553  
 — общая 553  
 — частичная 553  
 Склероз артериол 86  
 — артерий мелких 86  
 — ладонных апоневрозов 353  
 — множественный 229  
 Склерома гортани 514  
 Сколиоз 3 99  
 Скополамин, отравление 691 Скорая  
 помощь психиатрическая  
 269 Скорбут 128 Скрофулодерма 554  
 Слабительные средства, рецепты  
 789, 815 Слабость родовой деятельности  
 457 Слизистая сумка, острое воспаление  
 335  
 — — хроническое воспаление 335  
 Слизистые средства, рецепты 815  
 Слоновость 399  
 Снотворные, отравление 670  
 — средства, рецепты 815  
 Совкаин, отравление 676  
 Согревающий компресс 622  
 Солнечный удар 657  
 Соляная кислота, отравлен.те 691  
 Сонбутал, отравление 670  
 Соски, трещины 461  
 Сосудорасширяющие средства, рецепты 817  
 Сосудосуживающие средства, рецепты 812  
 Спазмофилия 299  
 Спинная сухотка 229  
 Спинномозговая анестезия 330  
 Спирт(ы), отравление 691  
 — амиловый, отравление 691  
 — винный, отравление 691  
 Спиртовой компресс 622  
 Спондилолистез 399  
 Спорынья, отравление 692  
 Средостение, воспаление 360  
 Сроки изоляции заразных больных  
 и соприкасающихся с ними 189  
 — инкубационного периода 180  
 Стафилококковая вакцина 754  
 Стенокардия 117  
 Стерилизация 624  
 Столбняк 169  
 Стоматит 591  
 — гангренозный 592  
 — катаральный 591  
 — поверхностный 591  
 — простой 591  
 — хронический 592  
 — язвенный 592 Стопа  
 конская 353  
 — плоская 400 Стрептококковая  
 поливалентная вакцина 755 Стрептомицин  
 738 Стрептоурокофен, рецепты 835  
 Стрептоцид белый, отравление 693  
 — красный, отравление 693  
 — эмульсия, рецепты 838  
 Стридор врожденный 301  
 Стрихин, отравление 692  
 Строфант, отравление 682  
 Строчки, отравление 693 Ступор  
 острый 256  
 — кататонический 258  
 Судороги 230 Сужение  
 пищевода 92  
 Сулема, антисептические свойства 332  
 — отравление 693 Сулемовая почка 83  
 Сульфазол, отравление 693  
 Сульфаниламидные препараты 758  
 — — отравление 693 Сульфат меди,  
 отравление 694 Сульфидин, отравление  
 693  
 — эмульсия 837 Сумеречное состояние 257  
 Сурьма, препараты, отравление 687  
 Сустав(ы) болтающийся 401  
 — гнойное воспаление 401  
 — коленный туберкулез 406  
 — контрактура 353  
 — неподвижность 330  
 — ограничение подвижности 353  
 — серозное воспаление 402  
 — тазобедренный туберкулез 406

Сустав(ы) туберкулез 405  
 Суставная мышь 402  
 Сухая дизентерийная вакцина 752  
 Сухожилие, разрыв 387  
 Сухотка спинного мозга 230  
 Схватки родовые судорожные 458  
 Сыпной тиф 171  
 — — психозы 243  
 Сырный яд, отравление 686  
 Табак, отравление 695  
 Таблетки азиатские, рецепты 835  
 — «Бло», рецепты 836  
 Тазобедренный сустав, деформации  
 347 Тахикардия пароксизмальная 89  
 Твердый шанкр 565 Тендовагинит  
 гнойный 402  
 — крепитирующий 403  
 Теофедрин, рецепты 769  
 Тепловой удар 657  
 Термопис, отравление 695  
 — рецепты 836 Терпентин, отравление 691  
 Терпентинное масло, отравление 691  
 Тетровакцина 756 Тетрахлорметан,  
 отравление 696 Тетразилсинец,  
 отравление 695  
 — — психозы 240 Тиокаин,  
 отравление 676  
 Типы нервной системы, определение  
 по И. П. Павлову 263 Токсикоз  
 беременности 428 Толуидин, отравление  
 665. Тонзиллит 514 Торможение в коре  
 головного мозга  
 263 Травматизм в родах, профилактика  
 458 Травматическая асфиксия 403  
 Травматические психозы 254  
 Травматический шок 412 Травмы  
 мозга 231 Трахеит 118 Трахома 534  
 — исход 53 4  
 — последствия 534  
 Трещины сосков 461  
 Тривакцина 756 Тридион,  
 рецепты 770 Триметин,  
 рецепты 770 Трипазол,  
 рецепты 836 Триппер 561  
 Трипротамин-цинк-ййсулин, отравление  
 673  
 Трихинелла 54  
 Трихинеллез 54  
 Трихлоруксусная кислота, отравление 697  
 Трихофития 545  
 — гладкой кожи 545  
 — глубокая кожи 545  
 — головы глубокая 545  
 — — поверхностная 545  
 — ногтей 545  
 Трихоцефаллез 54  
 Тромбопения 119  
 Тромбофлебит 404  
 Трудовая терапия 268  
 Туберкулез 301  
 — гортани 514  
 — кишок 120  
 — кожи 554  
 — — язвенный 554  
 — коленного сустава 406  
 — костей 405  
 — легких 120, 302  
 — — особенности течения у детей  
 — милиарный 120  
 — позвоночника 406  
 — почки 407  
 — психозы 244  
 — суставов 405  
 — — тазобедренных 406 Туберкулезная  
 вакцина БЦЖ 755 Туберкулезный артрит  
 104 Туберкулид папуло-некротический  
 554 Туляремийная вакцина 755  
 Туляремия 172  
 Угарный газ, отравление 696 Углерод  
 четыреххлористый, отравление 696 Угри  
 белые 556  
 — простые 555  
 — черные 556 Удушье 658 Удушение  
 плода 420 Укрепляющие средства 819  
 Уксусная кислота, отравление 697  
 — эссенция, отравление 697 Укусы  
 змей, отравление 697  
 — — первая помощь 658  
 — насекомых 658  
 — ос 659  
 — пчел 659  
 — шмелей 659 Уремия  
 84 Уретра, сужение 401  
 Уретрит гонорройный, осложнение  
 561 Уросал, рецепты 836  
 Успокаивающие нервную систему  
 средства, рецепты 820  
 Утопление 659 Ушиб 407  
 Ущемление матки 492  
 Фарингит 515  
 Фельдшера, правила выписки рецептов  
 705  
 ,  
 Фенадон, рецепты 769  
 Фенацетин, отравление 665  
 Фенол, отравление 697  
 Фиброаденома молочной железы 408  
 Фиброзные остеоидистрофии 408'  
 Фиброзный остит 371  
 Фибромиома матки 485  
 Физиологические нормы питания в СССР  
 309  
 Физостигмин, отравление 697  
 Фимоз 409  
 Фитонциды, рецепты 744  
 Флаваргин, отравление 698  
 Флегмона 410



## II

Abortus 417  
 — completus 417  
 — imminuens 417  
 — incompletus 417  
 — incipiens 417  
 Abscessus 325  
 — apiculiculis 325  
 — cerebri 326 ~  
 hepatis 326  
 — lateropharyngealis 495  
 — peritonsillaris 496  
 — pulmonis 9  
 — retropharyngealis 495  
 — septi nasi 496  
 — subdiaphragmaticus 327  
 Achylia gastrica 33  
 Acne vulgaris 555  
 Aconitum napellus, отравление 668  
 Acromegalia 16  
 Actinomycosis 327  
 Adenoma 537  
 Adipositas 88  
 Adnexitis 467  
 Adonis vernalis, отравление 682  
 Agaricus muscarius, отравление 681  
 Agranulocytosis 14  
 Albomycinum 741  
 Alopecia 550  
 Amanita phalloides, отравление 686  
 — ■ — mappa, отравление 688  
 — — tar. vernalis, отравление 686  
 Amenorrhoea 468  
 Amoebiasis 143  
 Anaemiae 21  
 — acuta 358  
 — perniciosa 23  
 Aneurysma 329  
 Angicholitis 126  
 Angina catarrhalis acuta 497  
 — follicularis 498  
 — intercostalis 497  
 — lacunaris 497  
 — Ludovici 498  
 — pectoris 117  
 — ulcero-membranacea 498  
 Angioma 328  
 Ankylosis 330 Anthrax  
 166 Antidotum arsenici  
 681  
 — metallorum 681  
 anuria 332  
 Aortitis 25

Aphthae epizooticae 179  
 Apoplexia cerebri 212  
 Appendicitis 332  
 — chronica 334  
 Arachnoiditis 209  
 Arteriosclerosis 31  
 — cerebri 209  
 Arthritis 103  
 — brucellosa 104  
 — deformans 102  
 — dysenteries 104  
 — gonorrhoea 561  
 — infectiosa 104  
 — purulenta 401  
 — serosa 402  
 — urica 102  
 Ascites 336 Asphyxia  
 420  
 — neonatorum 421  
 Asthma bronchialis 27  
 — cardiale 30 Atheroma 335  
 Atelectasis pulmonum 277  
 Atherosclerosis 31 Atresia ani  
 277  
 — vaginae 470  
 Atropa belladonna, отравление 667  
 Atrophia cutis 537 Avitaminosis A 517  
 \*

Balanitis 537  
 Balanoposthitis 537  
 Balbuties 212 Bigumalum  
 765 Bleorrhoea 523  
 Blepharitis sicca 517  
 — ulcerosa 518  
 Botulismus 137  
 Brassica juncea, отравление 671  
 — nigra, отравление 671  
 Bronchadenitis tuberculosa 121  
 Bronchitis acuta 38, 278  
 — chronica 39, 278  
 Bronchoectasia 40  
 Bronchopneumonia 100  
 Brucellosis 138  
 Bulbils scillae, отравление 682  
 Bursitis acuta 335  
 — chronica 335

Calculus vesicae urinariae 352  
 — dentalis 583

Cancer laryngis 513  
 — linguae 392  
 — mammae 389  
 — oesophagi 391  
 — recti 391  
 — uteri 489  
 — ventriculi 389  
 Cantharides или Lytta vesicatoria,  
 отравление 702  
 Carbunculus 352  
 Carcinoma 388  
 Cardiosclerosis 66  
 Caries dentis 584  
 Cataracta 525  
 — senilis 525  
 — zonularis 525  
 Causalgia 214  
 Cephalicis Ipecacuanha, отравление  
 674 Cephalgia 211 Cerumen 514  
 Chalasion 523 Chloromycetinum  
 743 Chlorosis 126 Cholangitis 126  
 Cholecystitis 126 Cholera asiatica  
 174 Chorea minor 232 Cicuta virosa,  
 отравление 684 Cirrhosis hepatis  
 127 Claudicatio intermittens 233  
 Climax 480 Colitis acuta 67  
 — chronica 69; 289  
 Colchicum autumnale, отравление  
 677 Colpitis 473  
 Coma diabeticum 56  
 Combustio 367  
 — oesophagi 369  
 Comedo 556  
 Commotio cerebri 231; 361  
 Compressio cerebri 360  
 Condyloma acuminata 481  
 Congelatio 372  
 Conium maculatum, отравление 684  
 Conjunctivitis acuta 528  
 — chronica 529  
 — diphtherica 528  
 — follicularis 528  
 — trachomatosa 534 Contractura  
 aponeurosis palmaris 353  
 — arthrosis 353  
 Contusio 407 «  
 — cerebri 231; 361 Convallaria,  
 majalis, отравление 682 Cor pulmonale  
 71 Coronaroscclerosis 66  
 Coryza 508  
 Coxa vara 347  
 Coxitis tuberculosa 406  
 Cystoma ovarii 480  
 Cytosis simplex 553  
 Cytisus laburnum, отравление 664

Dacryocystitis 520  
 Decubitus 385  
 Dentitio 589

## 55\*

Dermatitis 540  
 — herpetiformis Duhring 53?  
 Descensus uteri 482  
 — vaginae 482 Diabetes  
 insipidus 56  
 — mellitus 56 Diarrhoea  
 105 Dicumarinum 767  
 Dilatio ventriculi 110  
 Diathesis urica 102  
 Dibasolum 766  
 Digitalis ambigua, отравление 682  
 — ferruginea, отравление 682  
 — lanata, отравление 682  
 — purpurea, отравление 682  
 Dipheninum 768 Dimedrolum 767  
 Diphtheria 152  
 Distorsio 396 Diverticulum  
 Meckeli 347  
 — oesophagi 347  
 Dystrophia alimentaris 16  
 — hepatis acuta 428  
 — musculorum progressiva 218  
 — myocardii 77  
 Dysenteria bacillaris 144  
 Dyshydrosis 541  
 Dysmenorrhoea 478  
 Dyspepsia simplex 285  
 —, toxica 286

Echinococcus 414  
 — hepatis 414  
 Eclampsia 461  
 Ecmolium 741  
 Ectropium palpebrae 520  
 Eczema 556  
 Ecthyma 549 Elephantiasis  
 399 Empiema 95; 293  
 Emphysema pulmonum 129  
 Encephalitis 176 Endocarditis  
 130 Endometritis 492  
 — gonorrhoea 492  
 Enteritis acuta 131  
 — chronica 132 Enuresis  
 nocturna 222  
 Epidermophytia 559  
 Epididymitis 413 Epilepsia  
 233 Epispadia 413  
 Epithelioma 552 Ephelides  
 538 Erosio colli uteri 493  
 Erysipelas 165  
 Erythema exsudativum multiforme  
 560  
 — nodosum 560  
 Erythrasma 560  
 Erythrinum 739  
 Extractum Filicis maris aethereum,  
 отравление 685

Favus 548  
 Fibroadenoma mammae 408  
 Fibromyoma uteri 485 Fissura  
 ani 404

- Fistulae 397; 491  
Fistula urinaria 397  
— intestinalis 397  
Flaor 470  
Folliculitis 556  
Fracturae 377  
— mandibulae 385  
Fructus cocculi, отравление 685  
— colocynthis, отравление 677  
Fungus umbilici 298  
Furamomum 769  
Furunculus 410  
— nasi 516  
Furunculosis 411  
Ganglion 341  
Gangraena 341  
— puimonum 9  
— pulpaе 590  
— spontanea 341  
Gastritis acuta 42  
— chronica 44  
Gastroenterocolitis acuta 47  
Gastroenteritis acuta 279  
Gastroptosis 46  
Gemelli 426 Genu valgum 347  
— varum 347  
Gingivitis simplex 591  
Glaucoma 521  
— secundaria 522  
Glioma retinae 522  
Glossitis purulenta 416  
Gonitis tuberculosa 406  
Gonoblenorrhoea conjunctivae 522  
Gonorrhoea 476; 561  
Gramicidin 732 Graviditas cervicalis 423  
— extrauterine 423  
Grippus 142  
Haematomesia 70  
Haematoma 342  
— septi nasi 502  
Haematuria 343  
Haemorrhagia 355  
— intestinalis 357  
— subconjunctival 530  
Haemophilia 47 Haemoptoe 70  
Haemothorax 70  
Helvella esculenta, отравление 693  
Helminthiasis 282 Hemisphera 217  
Hemiplegia et Diplegia spastica infantilis 225  
Hepatitis chronica 127  
— luetica 116  
— parenchymatosa acuta 48  
Herpes simplex 344  
— tonsurans 545  
— zoster 543  
Hernia abdominalis 345  
— femoralis 345  
— incarcerata 346  
— inguinalis 345  
— lineae albae 345  
— postoperativum 346  
Hernia traumatica 346  
— umbilicalis 346  
Holelithiasis 60  
Hordeolum 536  
Hygroma 343  
Hydradenitis submaxillaris 344  
Hydrocephalus 210  
Hydronephrosis 344  
Hydrocele 337  
Hydrops vesicae felleae 336  
Hydrothorax 49  
Hyoscyamus niger, отравление 667  
Hyperaciditas 44  
Hyperhydrosis 550  
Hyperthyreosis 34  
Hypertrichosis 539  
Hypermetropia 524  
Hypertrophia prostatae 384  
Ichthyosis 542 Icterus catarrhalis 35  
— haemolyticus 23  
— infectious leptospiroa 154  
— neonatorum physiologica 288  
— symptomatologica 288  
Ileus 366  
Impetigo contagiosa 549  
— vulgaris 549  
Incarcerate uteri 492 Incisio 386  
Infarctus myocardi 64  
— puimonum 63  
Influenza 142 Insomnia 210  
Intertrigo 291; 548  
Invaginatio intestini 349  
Iritis 519  
Ischias 214  
Juniperus sablna, отравление 680  
Keratitis parenchymatosa 526 Keratoconjunctivitis tuberculosa 527  
laryngitis acuta 505 \*  
— chronica 505  
— cruposa 504  
— subclordalis 505  
Leishmaniosis 156  
— cutis 157  
Leptospirosis icterohaemorrhagica  
Leukaemia 72  
Leukoplakia 592  
Levomycetinum 743  
Lichen ruber planus 543  
Lymphogranulomatosis inguinalis 580  
Lipoma 358  
Lues 565  
Lumbago 76, 215  
Lupus erythematoses 539  
— vulgaris 555  
Luxatio 337  
— femoris congenita 338  
— habitualis 338  
Lymphadenitis 358  
Lymphangitis 357

- Lymphadenitis tuberculosa 404  
Lysozimuin 742  
Malaria 158  
— quartana 158  
— tertiana 158  
— tropica 158  
Malleus 165  
Mastitis 481  
— neonatorum 284 Mastoiditis acuta 506  
Mastopathia 359  
Mediastinitis 360 Melaena neonatorum 28,9  
Meningitis purulenta 216  
— serosa 216 tuberculosa 217  
Meteorismus 75  
Metritis 484  
Metroendometritis 492  
Microcephalia 218  
Microsporia 547 Milium 556  
Missed abortion 418 Mola hydatidosa 430  
Molluscum contagiosum 547 Morbilli 155  
Morbus Adelsoni 15  
— Bangi 138  
— Basedowi 34  
— Botkini 35  
— hypertonicus 49  
— Werlhofii 119  
— Paget 408  
— pappasii 161  
— Vasilievi-Weili 154  
Mus articularis 402  
Myelitis 219  
Myocardiodystrophia 77  
Myocardopathia 78  
Myocardiosclerosis 66  
Myocardiosclerosis 66  
Myocarditis acuta 78  
— chronica 79  
Myositis 76  
Myopia 518  
Myxoedema 76  
Naevus 552  
Nejronephrosis 83  
Nephritis acuta 84  
— chronica 85  
— insularis 85  
Nephroangiosclerosis 86  
Nephrolithiasis 108  
Nephrosis 87  
— lipidea 87  
Nephroposis 109  
Nephrosclerosis 86  
Neuralgia 219  
Neurasthenia 220  
Neuroma 366 Neuritis 221  
— n. cochlearis 509  
— mediani 221  
— peronei 221  
Neuritis n. radialis 221  
— ulnaris 221  
Neurolues 229  
Nephropathia gravidarum 431  
Neurosis cordia 82  
— intestini 81  
— ventriculi 80  
Neuvenum 771  
Nicotiana rustica, отравление 095  
Noma 367  
Obstipatio 61; 288  
Oedema papillae n. optici 524  
— puimonum 89  
Oesophagitis 92  
Oesophagospasmus 81  
Onychomycosis 547  
Ophthalmia electrica 530  
— sympathica 533 Orchitis 370  
Osteomyelitis acuta 370  
— chronica 371  
— maxillae mandibulae 385  
Otitis externa acuta circumscripta 516  
— media acuta 501  
— purulenta chronica 502  
Otosclerosis 510  
Ozaena nasi 508  
Parturitium 373  
— articulare 375  
— cutaneum 374  
— ossale 374  
— subcutaneum 374  
— unguis 374 Pancreatitis 375  
Panophthalmitis 531  
Paralysis agitans 225  
— n. facialis 215  
— progressiva 250  
Parametritis 487  
Paranephritis 76  
Paratyphus A 168  
— B 168 Paraphimosis 409  
Paraproctitis 376  
Parodontosis 581 Parotitis epidemica 178  
— purulenta 377 Pavor nocturnus 223  
Pediculosis 539  
Pellagra 90  
Peloidinum 772  
Pelveoperitonitis 487 Perforatio intestinum 385  
— oesophagi 38 Pericarditis 91  
Pericementitis 587  
Perichondritis laryngis 511  
Periodontitis acuta 587  
— chronica 588  
Periostitis 380  
Peritonitis 380  
Pertussis 154  
Pernio 547  
Pes planus 400

- Pes equinus 353  
 ----- varus 354  
 Pestis 175  
 Pharyngitis 515  
 Phenadonum 769  
 Phlegmonae 410  
 — orbitae 535  
 Phimosi 409  
 Pyonephrosis 381  
 Pityriasis rosea (Gibert) 544  
 — versicolor 544 Placenta praevia  
 439 Pleuritis exsudativa serosa 93  
 — purulenta 95; 293  
 — sicca 95 Pleuropneumonia  
 96 Pneumococcosis 96  
 Pneumonia catarrhalis 100  
 — oroposa 96; 296  
 — lobularis 100 Pneumothorax  
 101 Podagra ID2 Polyarthriti  
 dysenterica 104  
 — deformans 102  
 — infectiosa 104  
 — rheumatica acuta 103  
 — chronica 104  
 — urica 102  
 Poliomyelitis anterior acuta 227  
 Polyneuritis 226 Polypus auris 513  
 — nasi 512  
 — uteri 488  
 Preeclampsia 461  
 Presbyopia 524  
 Prolapsus recti 339  
 — uteri 482  
 — vaginae 482  
 Prostatitis 384  
 Prurigo 551 Pruritis  
 541  
 — vulvae 475  
 Pseudoarthrosis 385  
 Psoriasis vulgaris 546  
 Psychasthenia 250  
 Psychosis manico-depressiva 246  
 Pterygium 530 Ptosis 531 Pulpitis 590  
 — acuta 590  
 — chronica 590 Pyelitis 92;  
 293 Pylorospasmus 293  
 Pylorostenosis 293  
 Pyoderma 549 Pyorrhoea  
 alveolaris 581  
 Bablez 136 Rachitis  
 298 Eadiculitis 228 Ren  
 mobili 109; 383 Rstentio  
 lochiorum 428  
 — testicul 349  
 — urinae 361 Retinitis 520  
 Reumocarditis HI Rhinitis  
 acuta (coryza) 508  
 — atrophica 507  
 Rhinitis chronica 509  
 Rubeola 156  
 Salpingitis 467 Sarcoma 396  
 Scabies 556 Schizoprenia  
 258 Scarlatina 168  
 Scleroderma 555 Scleroma  
 laryngis 514 Sclerosi  
 multiplex 229  
 aponeurosis palmaris  
 Scoliosis 399 Scorbutus 128  
 Scrofuloderma 556  
 Seborrhoea 552  
 Secale cornutum, отравление C  
 Semen Ricini, отравление 687  
 — Sabadillae, отравление 688  
 — Strophanthi, отравление 682 Sepsis  
 398  
 — neonatorum 300  
 Septicaemia 398  
 Septicopyaemia 398  
 Singultus 212 Soor 290  
 Spasmus 230  
 Spondylitis tuberculosa 406  
 Spondylolisthesis 399  
 Stenocardia 117 Stenosis  
 oesophagi 92  
 — ostii aortae 106  
 — atrio-ventricularis sinistri 106  
 Sterilitas 472  
 Strabismus 529 Strictura  
 oesophagi 400  
 — urethrae 401  
 Stomatitis 591  
 — fibrinosa 591  
 — ulcerosa 592  
 Streptomycinum 738  
 Struma endemica 63  
 Strychnos nux vomica, отравление  
 692  
 Sudamina 551 «  
 Syphilis 565  
 — cutanea tuberculosa 566  
 — congenita 567  
 — hepatis 116  
 — gummosa 566 Sycosis simplex 553  
 Symptomocomplex Menieri 506  
 Syntomycinum 771 Syringomyelia  
 229  
 Tabes dorsalis 230  
 Tendovaginitis crepitans 403  
 — purulenta 402  
 Tetanus 169  
 Theophedrinum 769  
 Thermopsis lanceolata, отравление 695  
 Thrombophlebitis 40.4  
 Tonsillitis chronica 514  
 Torticollis 76; 354 Tracheitis  
 118 Trachoma 534  
 Trichophytia 545

- Trichophytia profunda 545  
 — superficialis 545  
 Trimetinum 770  
 Trombopenia 119  
 Tuberculosis 301  
 — cutis 534  
 — intestini 120  
 — laryngis 514  
 — miliaris 121  
 — ossium 405  
 — pulmomin 120; 302  
 — renis 407 Tularemia  
 172 Tumor cerebri 223  
 — mellullae spinalis 224  
 Typhus abdominalis 139  
 — exanthematicus 171  
 — recurrens 141  
 Ulcera 415  
 — puerperalia 461  
 Ulcus 415  
 — ■ cruris varicosa 415  
 — duodeni 132  
 — molle 563  
 — pepticum 415  
 — serpens corneae 535  
 Ulcus ventriculi 132  
 — umbilici 298 Unguis  
 incarceratus 367 Urethritis  
 gonorrhoea 561  
 — chronica 561  
 Urticaria 542  
 Vaginitis 473  
 Varices haemorrhoidales 343  
 — venarum 335  
 Varicocele 336  
 Varicella 161  
 Variola vera 162  
 Vegetationes adenoidae 496  
 Veratrum Lobelianum, отравление  
 669 Versio fetus  
 434 Vertigo 211  
 Vitium cordis 106  
 Vitiligo 549  
 Volvulus intestinorum 349  
 Vomitus 110  
 — gravidarum 453  
 Vulnura 392  
 Vulvitis 474  
 Vulnus oculi perforatis 533  
 Vulvo-vaginitis 475

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Предисловие к четвертому изданию .....                                                                | 3  |
| Предисловие к третьему изданию .....                                                                  | 6  |
| Предисловие к первому изданию .....                                                                   | 8  |
| Г л а в а I. Внутренние болезни. Кандидат мед. наук<br>В. И. Кристман.....                            | 9  |
| Абсцесс (гнойник) легкого. Гангрена (омертвление) легкого .                                           | 9  |
| Абсцесс печени см. гл. VI Хирургические болезни .....                                                 | 12 |
| Авитаминоз (Гиповитаминоз) А см. гл. X. Заболевания глаз .                                            | 12 |
| Авитаминоз (Гиповитаминоз) B <sub>1</sub> .....                                                       | 12 |
| Авитаминоз (Гиповитаминоз) B <sub>2</sub> .....                                                       | 13 |
| Авитаминоз (Гиповитаминоз) С см. Цынга .....                                                          | 13 |
| Авитаминоз (Гиповитаминоз) D см. гл. V Детские болезни.<br>Рахит.....                                 | 13 |
| Авитаминоз (Гиповитаминоз) К.....                                                                     | 13 |
| Авитаминоз (Гиповитаминоз) РР см. Пеллагра .....                                                      | 14 |
| Авитаминозы (Гиповитаминозы) .....                                                                    | 14 |
| Агранулоцитоз .....                                                                                   | 14 |
| Аддисонова болезнь. Бронзовая болезнь.....                                                            | 15 |
| Акромегалия.....                                                                                      | 16 |
| Актиномикоз легких см. гл. VI Хирургические болезни ....                                              | 16 |
| Алиментарная дистрофия..... №                                                                         | 18 |
| Алиментарно-токсическая алейкия (Септическая ангина) . .                                              | 18 |
| Амилоидный нефроз см. Нефроз липоидно-амилоидный ...                                                  | 20 |
| Ангина см. гл. IX Заболевания уха, носа, горла ...*                                                   | 20 |
| Ангина септическая см. Алиментарно-токсическая алейкия .                                              | 20 |
| Ангиохолит см. Холецистит .....                                                                       | 20 |
| Аневризма аорты см. Аортит .....                                                                      | 20 |
| Анемия. Мдлокровие: .....                                                                             | 21 |
| Анемия агастрическая .....                                                                            | 22 |
| Анемия апластическая .....                                                                            | 22 |
| Анемия гемолитическая. Гемолитическая желтуха .....                                                   | 23 |
| Анемия злокачественная .....                                                                          | 23 |
| Анурия..... <sup>1</sup>                                                                              | 24 |
| Аортит. Воспаление аорты. Мезаортит. Сифилис аорты.<br>Аневризма аорты. Мешчатое расширение аорты ... | 25 |
| Аппендицит. Воспаление червеобразного отростка см. гл. VI<br>Хирургические болезни .....              | 26 |
| Аритмии. ....                                                                                         | 26 |
| Артериосклероз см. Атеросклероз.....                                                                  | 27 |
| Артрит брусцеллезный см. Полиартриты инфекционные . .                                                 | 27 |
| Артрит гонорройный см. Полиартриты инфекционные ...                                                   | 27 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Артрит дизентерийный см. Полиартриты инфекционные ...                                   | 27 |
| Артрит мочекаменный см. Подагра .....                                                   | 27 |
| Артрит сифилитический см. Полиартриты инфекционные . .                                  | 27 |
| Артрит туберкулезный см. Полиартриты инфекционные ...                                   | 27 |
| Артриты обезображивающие см. Полиартрит обезображиваю<br>щий деформирующий .....        | 27 |
| Астма бронхиальная .....                                                                | 27 |
| Астма сердечная .....                                                                   | 30 |
| Атеросклероз. Артериосклероз .....                                                      | 31 |
| Атония желудка см. Расширение желудка.....                                              | 33 |
| Атония кишечника, см. Запоры.....                                                       | 33 |
| Атрофия (дистрофия) печени желтая, острая см. Гепатит па-<br>ренхиматозный острый ..... | 33 |
| Ахилия желудка.....                                                                     | 33 |
| Базедова болезнь. Гипертиреозы .....                                                    | 34 |
| Белокровие см. Лейкемия. ....                                                           | 35 |
| Бери-бери см. Авитаминоз B <sub>1</sub> .....                                           | 35 |
| Бледная немочь см. Хлороз.....                                                          | 35 |
| Блокада сердца см. Аритмии .....                                                        | 35 |
| Блуждающая или подвижная почка см. Почка опущенная За                                   | 36 |
| Боткина болезнь. ....                                                                   | 36 |
| Бронхиальная астма см. Астма бронхиальная .....                                         | 38 |
| Бронхит острый.....                                                                     | 38 |
| Бронхит хронический .....                                                               | 39 |
| Бронхопневмония см. Пневмония очаговая.....                                             | 40 |
| Бронхоэктазия— расширение бронхов .....                                                 | 40 |
| Васильева-Вейля болезнь см. гл. II. Инфекционные болезни,<br>Инфекционная желтуха ..... | 41 |
| Верльгофа болезнь см. Тромбопения .....                                                 | 41 |
| Высотная болезнь. Горная болезнь..                                                      | 41 |
| Гангрена легкого см. Абсцесс легкого .....                                              | 42 |
| Гастрит острый. Острое воспаление желудка .....                                         | 42 |
| Гастрит хронический .....                                                               | 44 |
| Гастроптоз. Опущение желудка. ....                                                      | 46 |
| Гастроэнтероколит острый. Острое воспаление желудка и<br>кишок .....                    | 47 |
| Гельминтозы см. Глистныя заболевания. ....                                              | 47 |
| Гематурия см. гл. VI Хирургические болезни.....                                         | 47 |
| Гемолитическая желтуха см. Анемия гемолитическая .....                                  | 47 |
| Геморрагические диатезы.....                                                            | 47 |
| Геморрой см. гл. VI Хирургические болезни .....                                         | 47 |
| Гемоторакс см. Кровоизлияние в полость плевры .....                                     | 47 |
| Гемофилия. Кровоточивость .....                                                         | 47 |
| Гепатит (воспаление печени) паренхиматозный острый ....                                 | 48 |
| Гепатит сифилитический см. Сифилис печени.....                                          | 48 |
| Гепатит хронический см. Циррозы печени.....                                             | 48 |
| Гигантизм. ....                                                                         | 48 |
| Гидронефроз см. гл. VI Хирургические болезни.....                                       | 49 |
| Гидроторакс.....                                                                        | 49 |
| Гипертиреозы см. Базедова болезнь. ....                                                 | 49 |
| Гипертоническая болезнь.....*                                                           | 49 |



|                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Гипотиреозы см. <i>Микседема</i> .....                                                                                                                                    | 53 |
| Гипотония см. <i>Сердечно-сосудистая недостаточность</i> ....                                                                                                             | 53 |
| Глистные заболевания (см. также гл. V <i>Детские болезни</i> ) . .                                                                                                        | 53 |
| Горная болезнь см. <i>Высотная болезнь</i> .....                                                                                                                          | 56 |
| Грудная жаба см. <i>Стенокардия</i> .....                                                                                                                                 | 56 |
| Декомпенсация сердца см. <i>Сердечно-сосудистая недостаточность</i> .....                                                                                                 | 56 |
| Диабет несахарный. Несахарное мочеизнурение .....                                                                                                                         | 56 |
| Диабет сахарный. Сахарное мочеизнурение .....                                                                                                                             | 56 |
| Диспепсия бродильная. Диспепсия гнилостная см. <i>Поносы</i> .                                                                                                            | 58 |
| Дистрофия алиментарная см. <i>Алиментарная дистрофия</i> ...                                                                                                              | 58 |
| Дистрофия миокарда см. <i>Миокардиоз/дистрофия</i> .....                                                                                                                  | 58 |
| Дистрофия печени острая см. <i>Болезнь Боткина. Гепатит паренхиматозный острый</i> .....                                                                                  | 58 |
| Желтуха .....                                                                                                                                                             | 58 |
| Желтуха гемолитическая см. <i>Анемия гемолитическая</i> .....                                                                                                             | 59 |
| Желтуха инфекционная см. <i>Боткина болезнь. Гепатит, паренхиматозный острый</i> гл. II <i>Инфекционные болезни. Инфекционная желтуха</i> .....                           | 59 |
| Желтуха катаральная см. <i>Болезнь Боткина. Гепатит паренхиматозный острый</i> .....                                                                                      | 59 |
| Желтуха механическая см. <i>Желтуха</i> .....                                                                                                                             | 59 |
| Желтуха спирохетная см. гл. II <i>Инфекционные болезни. Инфекционная желтуха</i> .....                                                                                    | 59 |
| Желудочное кровотечение см. <i>Кровотечение желудочное</i> ...                                                                                                            | 60 |
| Желчнокаменная болезнь .....                                                                                                                                              | 60 |
| Запоры .....                                                                                                                                                              | 61 |
| Зоб эндемический .....                                                                                                                                                    | 63 |
| Инфаркт легкого .....                                                                                                                                                     | 63 |
| Инфаркт миокарда .....                                                                                                                                                    | 64 |
| Камни почек см. <i>Почечнокаменная болезнь</i> .....                                                                                                                      | 66 |
| Кардиосклероз. Миокардиосклероз. Миокардиозирроз ...                                                                                                                      | 66 |
| Катарр желудка см. <i>Гастрит хронический</i> .....                                                                                                                       | 66 |
| Катарральная пневмония см. <i>Пневмония очаговая</i> .....                                                                                                                | 67 |
| Кишечное кровотечение см. <i>Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Гл. II Инфекционные болезни, Брюшной тиф. Дизентерия. Гл. VI Хирургические болезни.</i> | 67 |
| Колит острый. Воспаление слизистой оболочки толстых кишок .....                                                                                                           | 67 |
| Колит хронический .....                                                                                                                                                   | 69 |
| Коллапс см. <i>Сердечно-сосудистая недостаточность острая.</i>                                                                                                            | 70 |
| Кома гипогликемическая см. <i>Диабет сахарный</i> .....                                                                                                                   | 70 |
| Кома диабетическая см. <i>Диабет сахарный</i> .....                                                                                                                       | 70 |
| Кома уремическая см. <i>Уремия. Нефрит хронический, нефроангиосклероз</i> .....                                                                                           | 70 |
| Коронаросклероз см. <i>Кардиосклероз. Стенокардия</i> .....                                                                                                               | 70 |
| Коронаротромбоз см. <i>Инфаркт миокарда</i> .....                                                                                                                         | 70 |
| Кретинизм см. <i>Зоб эндемический</i> .....                                                                                                                               | 70 |
| Кровавая рвота см. <i>Кровотечение желудочное</i> .....                                                                                                                   | 70 |
| Кровоизлияние в полость плевры. Гемоторакс .....                                                                                                                          | 70 |
| Кровотечение желудочное .....                                                                                                                                             | 70 |

иц

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Кровотечение кишечное см. <i>Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Гл. II Инфекционные болезни Брюшной тиф. Дизентерия. Гл. VI Хирургические болезни</i> | 70 |
| Кровотечение легочное. Кровохаркание .....                                                                                                                              | 70 |
| Кровохаркание см. <i>Кровотечение легочное</i> .....                                                                                                                    | 70 |
| Крупозная пневмония см. <i>Пневмония крупозная</i> .....                                                                                                                | 71 |
| Легочное сердце .....                                                                                                                                                   | 71 |
| Лейкемия (лейкоз) белоокровие .....                                                                                                                                     | 72 |
| Лейкемия острая (острый лейкоз) см. <i>Лейкемия</i> .....                                                                                                               | 73 |
| Лейкопения .....                                                                                                                                                        | 73 |
| Лейкоцитоз .....                                                                                                                                                        | 74 |
| Лимфатическая лейкемия см. <i>Лейкемия</i> .....                                                                                                                        | 74 |
| Лимфогрануломатоз .....                                                                                                                                                 | 74 |
| Липоидный нефроз см. <i>Нефроз липоидный</i> .....                                                                                                                      | 74 |
| Люмбаго см. <i>Миозиты и миалгии</i> .....                                                                                                                              | 74 |
| Лямблиоз см. <i>Холецистит. Энтерит хронический</i> ....                                                                                                                | 74 |
| Малокровие СИ. Анемия .....                                                                                                                                             | 74 |
| Малокровие злокачественное см. <i>Анемия злокачественная</i> :-/.                                                                                                       | 75 |
| Мезаортит см. <i>Аортит</i> .....                                                                                                                                       | 75 |
| Мерцательная аритмия см. <i>Аритмии</i> .....                                                                                                                           | 75 |
| Метеоризм. Вздутие живота газами .....                                                                                                                                  | 75 |
| Миалгии см. <i>Миозиты и миалгии</i> .....                                                                                                                              | 78 |
| Микседема. Гипотиреозы .....                                                                                                                                            | 76 |
| Миозиты (воспаление мышц). Миалгии .....                                                                                                                                | 76 |
| Миокардиодистрофия .....                                                                                                                                                | 77 |
| Миокардиопатия. .                                                                                                                                                       | 78 |
| Миокардиосклероз см. <i>Кардиосклероз</i> .....                                                                                                                         | 78 |
| Миокардиозирроз см. <i>Кардиосклероз</i> .....                                                                                                                          | 78 |
| Миокардит острый. Острое воспаление сердечной мышцы . .                                                                                                                 | 78 |
| Миокардит хронический .....                                                                                                                                             | 79 |
| Мизлоидная лейкемия см. <i>Лейкемия</i> .....                                                                                                                           | 79 |
| Морская болезнь .....                                                                                                                                                   | 79 |
| Неврозы внутренних органов . , .....                                                                                                                                    | 80 |
| Невроз желудка .....                                                                                                                                                    | 80 |
| Неврозы кишечника .....                                                                                                                                                 | 81 |
| Непроз пищевода. Спазм пищевода .....                                                                                                                                   | 81 |
| Неврозы сердечно-сосудистые. ....                                                                                                                                       | 82 |
| Некронефроз. Сулемовая почка .....                                                                                                                                      | 83 |
| Несахарное мочеизнурение см. <i>Диабет несахарный</i> .....                                                                                                             | 84 |
| Нефрит острый .....                                                                                                                                                     | 84 |
| Нефрит очаговым .....                                                                                                                                                   | 85 |
| Нефрит хронический .....                                                                                                                                                | 85 |
| Нефроангиосклероз. Нефросклероз. Склероз артериол (мелких артерий) почек (первично сморщенная почка) . .                                                                | 86 |
| Нефроз .....                                                                                                                                                            | 87 |
| Нефроз липоидно-амилоидный .....                                                                                                                                        | 87 |
| Нефроз липоидный .....                                                                                                                                                  | 87 |
| Нефроптоз см. <i>Почка опущенная</i> . , .....                                                                                                                          | 88 |
| Обморок см. <i>Сердечно-сосудистая недостаточность острая и гл. XVI. Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях</i> .....                                   | 88 |

|                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ожирение. . . . .                                                                                                                                                             | 88  |
| Опушение желудка см. <i>Гастроптоз</i> . . . . .                                                                                                                              | 89  |
| Опушение почки см. <i>Почка опущенная</i> . . . . .                                                                                                                           | 89  |
| Отек легких. . . . .                                                                                                                                                          | 89  |
| Отеки безбелковые. Отеки голодные. Отечная болезнь см. <i>Алиментарная дистрофия</i> . . . . .                                                                                | 89  |
| Очаговая пневмония см. <i>Пневмония очаговая</i> . . . . .                                                                                                                    | 89  |
| Пароксизмальная тахикардия . . . . .                                                                                                                                          | 89  |
| Пеллагра . . . . .                                                                                                                                                            | 90  |
| Перикардит. Воспаление околосердечной сумки. . . . .                                                                                                                          | 91  |
| Пернициозная анемия см. <i>Анемия злокачественная</i> . . . . .                                                                                                               | 92  |
| Печеночная колика см. <i>Желчнокаменная болезнь</i> . . . . .                                                                                                                 | 92  |
| Пиопневмоторакс см. <i>Пневмоторакс</i> . . . . .                                                                                                                             | 92  |
| Пищевода воспаление . . . . .                                                                                                                                                 | 92  |
| Пищевода спазм см. <i>Невроз пищевода</i> . . . . .                                                                                                                           | 93  |
| Пищевода сужения . . . . .                                                                                                                                                    | 03  |
| Пищевые отравления см. гл. II <i>Инфекционные болезни. Гастрит острый. Гастронтероколит</i> и гл. XVI <i>Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях</i> . . . . . | 03  |
| Пизлит. Воспаление слизистой оболочки почечной лоханки . . . . .                                                                                                              | 03  |
| Плеврит выпотной, экссудативный, серозный . . . . .                                                                                                                           | 94  |
| Плеврит гнойный. Эмпиема . . . . .                                                                                                                                            | 95  |
| Плеврит серозный см. <i>Плеврит выпотной</i> . . . . .                                                                                                                        | 96  |
| Плеврит сухой . . . . .                                                                                                                                                       | 96  |
| Плеврит экссудативный см. <i>Плеврит выпотной</i> . . . . .                                                                                                                   | 96  |
| Плевропневмония см. <i>Пневмония крупозная</i> . . . . .                                                                                                                      | 06  |
| Пневмокониоз . . . . .                                                                                                                                                        | 96  |
| Пневмония аспирационная см. <i>Пневмония очаговая</i> . . . . .                                                                                                               | 97  |
| Пневмония вирусная см. <i>Пневмония очаговая</i> . . . . .                                                                                                                    | 97  |
| Пневмония катарральная см. <i>Пневмония очаговая</i> . . . . .                                                                                                                | 97  |
| Пневмония крупозная. Крупозное воспаление легких. Плевропневмония . . . . .                                                                                                   | 97  |
| Пневмония очаговая. Бронхопневмония. Катарральная пневмония . . . . .                                                                                                         | 100 |
| Пневмосклероз . . . . .                                                                                                                                                       | 101 |
| Пневмоторакс. Скопление воздуха в полости плевры . . . . .                                                                                                                    | 102 |
| Подагра. Артрит мочеислый . . . . .                                                                                                                                           | 102 |
| Полиартрит обезображивающий деформирующий . . . . .                                                                                                                           | 103 |
| Полиартрит ревматический острый . . . . .                                                                                                                                     | 103 |
| Полиартрит ревматический хронический . . . . .                                                                                                                                | 105 |
| Полиартриты инфекционные . . . . .                                                                                                                                            | 105 |
| Поносы . . . . .                                                                                                                                                              | 106 |
| Пороки сердца . . . . .                                                                                                                                                       | 106 |
| Почечная колика см. <i>Почечнокаменная болезнь</i> . . . . .                                                                                                                  | 108 |
| Почечной лоханки воспаление см. <i>Пиелит</i> . . . . .                                                                                                                       | 108 |
| Почечнокаменная болезнь . . . . .                                                                                                                                             | 108 |
| Почка опущенная. Блуждающая или подвижная почка . . . . .                                                                                                                     | 109 |
| Почка сулемовая см. <i>Некронефроз</i> . . . . .                                                                                                                              | 109 |
| Прострел см. <i>Миозиты и миалгии</i> . . . . .                                                                                                                               | 109 |
| Пульс. . . . .                                                                                                                                                                | 109 |
| Рак желудка см. гл. VI <i>Хирургические болезни</i> . . . . .                                                                                                                 | 110 |

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Рак других органов см. гл. VI <i>Хирургические болезни</i> . . . . .                                               | 110 |
| Расширение желудка . . . . .                                                                                       | 110 |
| Рвота . . . . .                                                                                                    | 110 |
| Рвота кровавая см. <i>Кровотечение желудочное</i> . . . . .                                                        | 111 |
| Ревматизм см. <i>Полиартрит ревматический. Ревмокардит</i> . . . . .                                               | 111 |
| Ревматический острый полиартрит см. <i>Полиартрит ревматический острый</i> . . . . .                               | 111 |
| Ревматический хронический полиартрит см. <i>Полиартрит ревматический хронический</i> . . . . .                     | 111 |
| Ревмокардит . . . . .                                                                                              | 111 |
| Сахарная болезнь см. <i>Диабет сахарный</i> . . . . .                                                              | 111 |
| Сахарное мочеизнурение см. <i>Диабет сахарный</i> . . . . .                                                        | 111 |
| Сердечная астма см. <i>Астма сердечная</i> . . . . .                                                               | 111 |
| Сердечно-сосудистая недостаточность острая. Коллапс. Шок. Обморок . . . . .                                        | 111 |
| Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая . . . . .                                                          | 113 |
| Сердечно-сосудистые неврозы см. <i>Неврозы сердечно-сосудистые</i> . . . . .                                       | 116 |
| Сердечный приступ см. <i>Астма сердечная. Инфаркт миокарда. Стенокардия. Неврозы сердечно-сосудистые</i> . . . . . | 116 |
| Сидероз см. <i>Пневмокониоз</i> . . . . .                                                                          | 116 |
| Силикоз см. <i>Пневмокониоз</i> . . . . .                                                                          | 116 |
| Сифилис аорты см. <i>Аортит</i> . . . . .                                                                          | 116 |
| Сифилис печени. Гепатит сифилитический . . . . .                                                                   | 116 |
| Скорбут см. <i>Цынга</i> . . . . .                                                                                 | 117 |
| Спазм пищевода см. <i>Невроз пищевода</i> . . . . .                                                                | 117 |
| Сужение пищевода см. <i>Пищевода сужение</i> . . . . .                                                             | 117 |
| Стенокардия. Грудная жаба . . . . .                                                                                | 117 |
| Сулемовая почка см. <i>Некронефроз</i> . . . . .                                                                   | 118 |
| Трахейт . . . . .                                                                                                  | 118 |
| Тромбозы. Верльгофа болезнь . . . . .                                                                              | 119 |
| Туберкулез кишок . . . . .                                                                                         | 120 |
| Туберкулез легких . . . . .                                                                                        | 120 |
| Туберкулез милиарный см. <i>Туберкулез легких</i> . . . . .                                                        | 126 |
| Туберкулез почек см. гл. VI <i>Хирургические болезни</i> . . . . .                                                 | 126 |
| Уремия см. <i>Нефрит острый. Нефрит хронический</i> . . . . .                                                      | 126 |
| Хлороз. Бледная немочь . . . . .                                                                                   | 126 |
| Холангит см. <i>Холецистит</i> . . . . .                                                                           | 126 |
| Холецистит. Воспаление желчного пузыря. Холангит или ангиохолит. Воспаление желчных протоков . . . . .             | 126 |
| Циррозы печени. Гепатиты хронические. Хроническое воспаление печеночной паренхимы . . . . .                        | 127 |
| Цынга . . . . .                                                                                                    | 128 |
| Чихотка легочная см. <i>Туберкулез легких</i> . . . . .                                                            | 129 |
| Шок см. <i>Сердечно-сосудистая недостаточность острая</i> и гл. VI <i>Хирургические болезни</i> . . . . .          | 129 |
| Экстрасистолия см. <i>Аритмии</i> . . . . .                                                                        | 129 |
| Эмпиема см. <i>Плеврит гнойный</i> . . . . .                                                                       | 129 |
| Эмфизема легких . . . . .                                                                                          | 129 |
| Эндокардит . . . . .                                                                                               | 130 |
| Энтерит острый. Острое воспаление слизистой оболочки толстых кишок . . . . .                                       | 131 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Энтерит хронический. Хроническое воспаление слизистой тонких кишок..... | 132 |
| Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки                     | 132 |
| Г л а в а II. Инфекционные болезни. Проф. М. В. Алексан                 |     |
| дров.....                                                               | 136 |
| Бешенство. Водобоязнь.....                                              | 136 |
| Болезнь Боткина. Эпидемический гепатит см. гл. I <i>Внутрен</i>         |     |
| ние болезни. Болезнь Боткина.....                                       | 137 |
| Ботулизм.....                                                           | 137 |
| Бруцеллез.....                                                          | 138 |
| Брюшной тиф.....                                                        | 139 |
| Возвратный тиф.....                                                     | 141 |
| Газовая гангрена см. гл. VI <i>Хирургические болезни</i> .....          | 142 |
| Грипп.....                                                              | 142 |
| Дизентерия амёбная.....                                                 | 143 |
| Дизентерия бациллярная.....                                             | 144 |
| Дифтерия.....                                                           | 152 |
| Инфекционная желтуха. Болезнь Васильева-Вейля ....                      | 154 |
| Кала-азар см. <i>Лейшманиоз</i> .....                                   | 154 |
| Коклюш.....                                                             | 154 |
| Корь.....                                                               | 155 |
| Краснуха.....                                                           | 156 |
| Лейшманиоз.....                                                         | 156 |
| Лихорадка паппатачисм. <i>Москитная лихорадка</i> .....                 | 158 |
| Малярия. Болотная лихорадка.....                                        | 158 |
| Менингит эпидемический. Цереброспинальный (эпидемиче                    |     |
| ское воспаление спинного и головного мозга).....                        | 160 |
| Москитная лихорадка. Лихорадка паппатачи.....                           | 161 |
| Оспа ветряная.....                                                      | 161 |
| Оспа натуральная.....                                                   | 162 |
| Паратифы А и В.....                                                     | 163 |
| Паротит эпидемический см. <i>Эпидемическое воспаление око</i>           |     |
| лоушной железы.....                                                     | 164 |
| Пендинская язва см. <i>Лейшманиоз</i> .....*                            | 164 |
| Пищевые токсикоинфекции. Пищевое отравление.....                        | 164 |
| Рожа.....                                                               | 165 |
| Сап.....                                                                | 165 |
| Свинка. Заушница см. <i>Эпидемическое воспаление околоушной</i>         |     |
| железы.....                                                             | 166 |
| Сибирская язва.....                                                     | 166 |
| Скарлатина. . . -.....                                                  | 168 |
| Столбняк.....                                                           | 169 |
| Сыпной тиф.....                                                         | 171 |
| Туляремия.....                                                          | 172 |
| Холера азиатская.....                                                   | 174 |
| Чума.....                                                               | 175 |
| Энцефалит. Воспаление головного мозга.....                              | 176 |
| Эпидемическое воспаление околоушной железы. Паротит                     |     |
| эпидемический. Свинка. Заушница.....                                    | 178 |
| Ящур.....                                                               | 179 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Д о б а в л е н и е I. Сроки инкубационного периода. . . .         | 180 |
| Д о б а в л е н и е II. Способы собирания материала для ла         |     |
| бораторного исследования..... Л.....                               | 182 |
| Д о б а в л е н и е III. Сроки изоляции заразных больных           |     |
| и соприкасающихся с ними.....                                      | 186 |
| Д о б а в л е н и е IV- Входные ворота инфекции. Пути вы           |     |
| деления инфекционного начала.....                                  | 200 |
| Д о б а в л е н и е V. Источники и путираспространения инфекции    | 202 |
| Д о б а в л е н и е VI. Возбудители важнейших эпидемических        |     |
| заболеваний и их жизнеспособность во внешней среде                 | 206 |
| Г л а в а III. Нервные болезни. Доцент М. Я. Турецкий. . . .       | 209 |
| Арахноидит. Воспаление паутинной оболочки мозга ....               | 209 |
| Артериосклероз головного мозга.....                                | 209 |
| Бессонница.....                                                    | 210 |
| Болезнь Гейне-Медина см. <i>Плиомиелит острый</i> .....            | 210 |
| Водянка головного мозга см. <i>Гидроцефалия</i> .....              | 210 |
| Гидроцефалия. Водянка. головного мозга.....                        | 210 |
| Головная боль.....                                                 | 211 |
| Головокружение.....                                                | 211 |
| Заикание.....                                                      | 212 |
| Икота.....                                                         | 212 |
| Инсульт. Мозговой удар.....                                        | 212 |
| Ишиас. Неврит или невралгия седалищного нерва.....                 | 214 |
| Каузалгия.....                                                     | 214 |
| Лицевого нерва паралич.....                                        | 215 |
| Люмбаго.....                                                       | 215 |
| Менингит (воспаление мозговых оболочек) гнойный ....               | 216 |
| Менингит серозный.....                                             | 216 |
| Менингит туберкулезный.....                                        | 217 |
| Менингит эпидемический цереброспинальный см. гл. II ....           |     |
| <i>Инфекционные болезни. Эпидемический цереброспинальный</i>       |     |
| <i>менингит</i> .....                                              | 217 |
| Мзгреиь.....                                                       | 217 |
| Микроцефалия.....                                                  | 218 |
| Миопатия.....                                                      | 218 |
| Мизлит инфекционный.....                                           | 219 |
| Невралгия.....                                                     | 219 |
| Неврастения.....                                                   | 220 |
| Неприт. Воспаление нерва.....                                      | 221 |
| Неврозы.....                                                       | 222 |
| Ночное недержание мочи.....                                        | 222 |
| Ночные страхи.....                                                 | 223 |
| Опухоль головного мозга.....                                       | 223 |
| Опухоль спинного мозга.....                                        | 224 |
| Паразиты мозга.....                                                | 224 |
| Паралич дрожательный.....                                          | 225 |
| Параличи детские мозговые.....                                     | 225 |
| Параличи периферические (родовые).....                             | 226 |
| Паркинсонизм см. гл. II <i>Инфекционные болезни. Энцефалит</i> , . | 226 |
| Полиневрит. .... ».....                                            | 226 |

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Полиомиелитострый. Воспаление передних рогов спинного мозга                                                                                              | 227 |
| Радикулит.....                                                                                                                                           | 228 |
| Сирингомиелия.....                                                                                                                                       | 229 |
| Сифилис нервной системы.....                                                                                                                             | 229 |
| Склероз множественный.....                                                                                                                               | 229 |
| Судороги.....                                                                                                                                            | 230 |
| Сухотка спинного мозга.....                                                                                                                              | 230 |
| Тики.....                                                                                                                                                | 231 |
| Травмы мозга.....                                                                                                                                        | 231 |
| Хорея.....                                                                                                                                               | 232 |
| Хромота перемежающаяся.....                                                                                                                              | 233 |
| Энцефалиты см. гл. II <i>Инфекционные болезни</i> .....                                                                                                  | 233 |
| Эпилепсия. Падающая болезнь.....                                                                                                                         | 233 |
| <br>Г л а в а IV. Психические заболевания. Проф. М. Я. Сергеевский.....                                                                                  | 235 |
| Алкогольные психозы.....                                                                                                                                 | 235 |
| Артериосклероз головного мозга. Гипертония.....                                                                                                          | 238 |
| Интоксикационные психозы.....                                                                                                                            | 240 |
| Инфекционные психозы.....                                                                                                                                | 242 |
| Инфекционные психозы, возникающие в связи с хроническими инфекциями см. <i>Прогрессивный паралич. Сифилис мозга. Энцефалит эпидемический и пр.</i> ..... | 244 |
| Истерия.....                                                                                                                                             | 244 |
| Маниакально-депрессивный психоз.....                                                                                                                     | 246 |
| Морфинизм.....                                                                                                                                           | 248 |
| Невроз навязчивости см. <i>Психастения</i> .....                                                                                                         | 249 |
| Олигофрения.....                                                                                                                                         | 249 |
| Прогрессивный паралич.....                                                                                                                               | 250 |
| Психастения.*.....                                                                                                                                       | 250 |
| Психозы реактивные (психогенные реакции).....                                                                                                            | 252 |
| Психозы симптоматические (так называемые).....                                                                                                           | 253 |
| Психозы, возникающие на почве болезней внутренних органов и общих заболеваний.....                                                                       | 253 |
| Психозы, возникающие в связи с внечерепными ранениями, остеомиелитом.....                                                                                | 254 |
| Травматические психозы.....                                                                                                                              | 254 |
| Ступор острый.....                                                                                                                                       | 256 |
| Сумеречное состояние.....                                                                                                                                | 257 |
| Шизофрения.....                                                                                                                                          | 258 |
| Энцефалиты.....                                                                                                                                          | 261 |
| Эпилептический статус (эпилепсия).....                                                                                                                   | 262 |
| Д о б а в л е н и е I. Общие понятия физиологии и патологии физиологии высшей нервной деятельности. Возбуждение и торможение в коре головного мозга..... | 263 |
| Д о б а в л е н и е II. Синдромы.....                                                                                                                    | 265 |
| Д о б а в л е н и е III. Общие правила организации помощи психически больным.....                                                                        | 267 |
| Д о б а в л е н и е IV- Скорая помощь при психических заболеваниях.....                                                                                  | 269 |

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Г л а в а V: Детские болезни. Под редакцией доктора медицинских наук И. М. Беркович.....                       | 276 |
| Астма бронхиальная.....                                                                                        | 276 |
| Асфиксия (Задыхание) новорожденных см. гл. VII <i>Акушерство</i> .....                                         | 277 |
| Ателектаз легкого.....                                                                                         | 277 |
| Атрезия (Отсутствие) заднепроходного отверстия.....                                                            | 277 |
| Анемия новорожденных врожденная (Гемолитическая болезнь).....                                                  | 277 |
| Бронхит острый.....                                                                                            | 278 |
| Бронхит хронический см. <i>Пневмония хроническая</i> .....                                                     | 278 |
| Бронхаденит см. <i>Туберкулез</i> .....                                                                        | 278 |
| Волчья пасть см. <i>Врожденные пороки развития</i> .....                                                       | 278 |
| Врожденные пороки развития.....                                                                                | 279 |
| Гастроэнтерит острый.....                                                                                      | 279 |
| Гельминтозы см. <i>Глистные заболевания</i> .....                                                              | 279 |
| Гипотрофия. Пониженное питание.....                                                                            | 279 |
| Глистные заболевания. Гельминтозы.....                                                                         | 282 |
| Грудных желез физиологическое набухание.....                                                                   | 284 |
| Грудница. Воспаление грудных желез новорожденных.....                                                          | 284 |
| Диатез невропатический.....                                                                                    | 284 |
| Диспепсия простая острая.....                                                                                  | 285 |
| Диспепсия токсическая.....                                                                                     | 286 |
| Желтуха новорожденных физиологическая.....                                                                     | 288 |
| Желтуха новорожденных симптоматическая.....                                                                    | 288 |
| Запоры.....                                                                                                    | 288 |
| Заячья губа см. <i>Врожденные пороки развития</i> .....                                                        | 289 |
| Колит острый. Слизисто-кровянистый понос см. гл. II <i>Инфекционные болезни. Дизентерия</i> .....              | 289 |
| Колит хронический.....                                                                                         | 289 |
| Кровавая рвота новорожденных. Мелена.....                                                                      | 289 |
| Кровоизлияния внутримозговые у новорожденных.....                                                              | 289 |
| Ларингит острый см. <i>Ложный круп</i> .....                                                                   | 290 |
| Ложный круп. Ларингит острый.....                                                                              | 290 |
| Мелена см. <i>Кровавая рвота новорожденных</i> .....                                                           | 290 |
| Молочница.....                                                                                                 | 290 |
| Недоношенные дети.....                                                                                         | 291 |
| Опрелость.....                                                                                                 | 291 |
| Переломы ключицы плечевой и бедренной кости у новорожденных.....                                               | 292 |
| Пилоростеноз.....                                                                                              | 292 |
| Пилороспазм.....                                                                                               | 293 |
| Пиэлит (пиурия). Воспаление почечных лоханок.....                                                              | 293 |
| Плеврит гнойный. Эмпиема.....                                                                                  | 293 |
| Пневмония мелкогнездная (Бронхопневмония мелкоочаговая катарральная).....                                      | 294 |
| Пневмония крупозная. Долевая крупноочаговая.....                                                               | 296 |
| Пневмония хроническая (Хроническая интерстициальная пневмония). Бронхоэктатическая болезнь. Пневмосклероз..... | 296 |
| Пневмония межплевральная (Острая интерстициальная).....                                                        | 297 |

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Пупка заболевания .....                                                                         | 298        |
| Рахит .....                                                                                     | 298        |
| Спазмофилия .....                                                                               | 299        |
| Сепсис новорожденных .....                                                                      | 300        |
| Стридор врожденный .....                                                                        | 301        |
| Туберкулез .....                                                                                | 301        |
| Туберкулез легких .....                                                                         | 302        |
| Хронические расстройства питания и пищеварения см. <i>Ги-<br/>потрофия</i> .....                | 303        |
| Эмпиема см. <i>Плеврит гнойный</i> .....                                                        | 303        |
| Д о б а в л е н и я . Питание детей первых лет жизни .....                                      | 303        |
| Физиологические нормы питания в СССР .....                                                      | 309        |
| Химический состав и калорийность наиболее употреби-<br>тельных пищевых продуктов .....          | 313        |
| Содержание витаминов в пищевых продуктах .....                                                  | 315        |
| Содержание минеральных веществ в пищевых продуктах .                                            | 320        |
| Содержание поваренной соли в пищевых продуктах ....                                             | 321        |
| Нормы выхода готовых изделий на 100 г продукта брутто.                                          | 322        |
| Г л а в а VI. Хирургические болезни. Проф. А. П. Вели-<br>корецкий и доцент В. А. Кружков ..... |            |
| Абсцесс. Гнойник .....                                                                          | 325        |
| Абсцесс аппендикулярный .....                                                                   | 325        |
| Абсцесс мозга .....                                                                             | • • • 326  |
| Абсцесс печени .....                                                                            | 326        |
| Абсцесс поддиафрагмальный .....                                                                 | 327        |
| Актиномикоз .....                                                                               | 327        |
| Анаэробная инфекция см. <i>Газовая гангрена</i> .....                                           | 328        |
| Ангиома .....                                                                                   | 328        |
| Аневризма (Расширение артерий) .....                                                            | 329        |
| Анестезия местная .....                                                                         | 329        |
| Анестезия спинномозговая .....                                                                  | 330        |
| Анкилоз, неподвижность в суставе .....                                                          | * . . 330  |
| Антисептический материал .....                                                                  | 331        |
| Антисептические средства .....                                                                  | 331        |
| Анурия .....                                                                                    | • . . 332  |
| Аппендицит. Воспаление червеобразного отростка слепой<br>кишки .....                            | Г- . . 332 |
| Аппендицит хронический .....                                                                    | 334        |
| Асфиксия см. <i>Наркоз</i> .....                                                                | 335        |
| Асцит см. <i>Водянка живота</i> .....                                                           | 335        |
| Атерома .....                                                                                   | 335        |
| Бурсит острый. Острое воспаление слизистой сумки . .                                            | Ж. 335     |
| Бурсит хронический. Хроническое воспаление слизистой<br>сумки .....                             | 335        |
| Варикозное (узловатое) расширение вен голени .....                                              | 335        |
| Варикозное. Расширение вен семенного канатика .....                                             | 336        |
| Водянка желчного пузыря .....                                                                   | 336        |
| Водянка живота. Асцит .....                                                                     | 336        |
| Водянка яичка .....                                                                             | 337        |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Воспаление брюшины см. <i>Перитонит</i> .....                                                     | 337       |
| Вывих .....                                                                                       | 337       |
| Вывих бедра врожденный .....                                                                      | 338       |
| Вывих привычный .....                                                                             | 338       |
| Выпадение прямой кишки .....                                                                      | 339       |
| Вытяжение .....                                                                                   | 339       |
| Газовая гангрена .....                                                                            | • . . 340 |
| Ганглий .....                                                                                     | 341       |
| Гангрена .....                                                                                    | 341       |
| Гемартроз .....                                                                                   | 342       |
| Гематома. Кровяная опухоль .....                                                                  | 342       |
| Гематурия .....                                                                                   | 343       |
| Геморрой .....                                                                                    | 343       |
| Гигрома .....                                                                                     | 343       |
| Гидраденит подмышечный. Воспаление потовых желез . . .                                            | 344       |
| Гидронефроз. Водянка почечных лоханок .....                                                       | 344       |
| Глоссит см. <i>Языка острое гнойное воспаление</i> .....                                          | 345       |
| Гнойник см. <i>Абсцесс</i> .....                                                                  | 345       |
| Гипертрофия предстательной железы, см. <i>Предстательной<br/>        железы гипертрофия</i> ..... | 345       |
| Грыжи .....                                                                                       | 345       |
| Деформации тазобедренного и коленного суставов .....                                              | 347       |
| Дивертикул Мекеля .....                                                                           | 347       |
| Дивертикул пищевода .....                                                                         | 347       |
| Диета послеоперационная .....                                                                     | 348       |
| Заворот кишок .....                                                                               | 349       |
| Задержка мочи см. <i>Мочеиспускания расстройства</i> .....                                        | 349       |
| Задержание яичка .....                                                                            | 349       |
| Закупорка общего желчного протока .....                                                           | 349       |
| Заушница см. <i>Паротит</i> .....                                                                 | 349       |
| Инвагинация. Внесение кишок .....                                                                 | 349       |
| Инородные тела .....                                                                              | 350       |
| Камня мочевого пузыря .....                                                                       | 352       |
| Карбункул .....                                                                                   | 352       |
| Соха vara см. <i>Деформации тазобедренного и коленного суставов</i>                               | 353       |
| Конская стопа .....                                                                               | 353       |
| Контактура Дюшоитрона. Склероз ладонного апоневроза .                                             | 353       |
| Контрактура (ограничение подвижности) сустава .....                                               | 353       |
| Косолапость .....                                                                                 | 354       |
| Кривошея . . g .....                                                                              | 354       |
| Крипторхизм, задержка яичек в полости живота или в па-<br>ховом канале .....                      | 355       |
| Кровотечение .....                                                                                | 355       |
| Кровотечение кишечное .....                                                                       | 357       |
| Лимфангоит. Воспаление лимфатических сосудов .....                                                | 357       |
| Лимфаденит. Воспаление лимфатических узлов .....                                                  | 358       |
| Липома .....                                                                                      | 358       |
| Малокровие острое .....                                                                           | 358       |
| Мастит хронический .....                                                                          | 359       |
| Материал для швов .....                                                                           | 359       |
| Медиастинит. Воспаление средостения. ....                                                         | 360       |

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Мозга сдавление .....                                              | 360   |
| Мочеиспускания расстройство .....                                  | 361   |
| Наркоз .....                                                       | 362   |
| Неврома .....                                                      | 366   |
| Непроходимость кишечника .....                                     | 366   |
| Ноготь вросший .....                                               | 367   |
| Нома. Водяной рак .....                                            | 367   |
| Обезболивание см. <i>Анестезия</i> .....                           | 367   |
| Ожог .....                                                         | 367   |
| Ожог пищевода .....                                                | 369   |
| Онихия см. <i>Панариций</i> .....                                  | 369   |
| Опухоли почек .....                                                | 369   |
| Орхит. Воспаление яичка .....                                      | 370   |
| Остеомизлит. Воспаление костного мозга и кости .....               | 370   |
| Остит фиброзный .....                                              | 371   |
| Острый живот .....                                                 | 372   |
| Отморозение .....                                                  | 372   |
| Панариций .....                                                    | 373   |
| Панкреатит .....                                                   | 375   |
| Паранефрит. Воспаление околопочечной клетчатки .....               | 376   |
| Парапроктит. Воспаление клетчатки около прямой кишки .....         | 376   |
| Парафимоз, см. <i>Фимоз</i> .....                                  | 377   |
| Паронихия см. <i>Панариций</i> .....                               | * 377 |
| Паротит гнойный. Воспаление околоушной железы (зауш<br>ница) ..... | 377   |
| Переломы .....                                                     | 377   |
| Периостит. Воспаление надкостницы .....                            | 380   |
| Перитонит. Воспаление брюшины .....                                | 380   |
| Пионефроз .....                                                    | 381   |
| Повреждения органов брюшной полости закрытые .....                 | 381   |
| Повреждения "позвоночника" .....                                   | 382   |
| Послеоперационный период .....                                     | 382   |
| Почка блуждающая, подвижная, смещенная .....                       | 383   |
| Почки повреждения .....                                            | * 383 |
| Почки туберкулез см. <i>Туберкулез почки</i> .....                 | 384   |
| Предстательной железы воспаление. Простатит .....                  | 384   |
| Предстательной Железы гипертрофия .....                            | 384   |
| Прободение желчного пузыря .....                                   | 385   |
| Прободение кишечника .....                                         | 385   |
| Прободение пищевода .....                                          | 385   |
| Пролежень .....                                                    | 385   |
| Псевдартроз. Ложный сустав .....                                   | 386   |
| Разрез гнойника .....                                              | 386   |
| Разрыв менисков коленного сустава .....                            | 387   |
| Разрыв сухожилия .....                                             | 387   |
| Рак .....                                                          | 388   |
| Раны .....                                                         | 392   |
| Раневое истощение .....                                            | 394   |
| Ранения брюшной полости .....                                      | 394   |
| Ранения грудной клетки .....                                       | 395   |
| Ранения черепа и мозга .....                                       | 396   |

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Растяжение связок суставов .....                                                                                                                 | 396 |
| Саркома .....                                                                                                                                    | 396 |
| Свищи .....                                                                                                                                      | 397 |
| Сдавление мозга см. <i>Мозга повреждения</i> .....                                                                                               | 398 |
| Сепсис хирургический.- Септицемия. Септикониемия .....                                                                                           | 398 |
| Сколиоз. ....                                                                                                                                    | 399 |
| Слоновость .....                                                                                                                                 | 399 |
| Сотрясение мозга см. <i>Мозга сса^мния</i> .....                                                                                                 | 399 |
| Спондилолистез .....                                                                                                                             | 399 |
| Стопа конская .....                                                                                                                              | 400 |
| Стопа плоская. .... % .....                                                                                                                      | 400 |
| Сужение пищевода .....                                                                                                                           | 400 |
| Сужение уретры .....                                                                                                                             | 401 |
| Сустав болтающийся .....                                                                                                                         | 401 |
| Сустава гной-ное воспаление .....                                                                                                                | 401 |
| Сустава серозное воспаление .....                                                                                                                | 402 |
| Суставная мышца .....                                                                                                                            | 402 |
| Тейдовагнит гнойный .....                                                                                                                        | 402 |
| Тендовагинит кренирующий .....                                                                                                                   | 403 |
| Травматическая асфиксия .....                                                                                                                    | 403 |
| Трещины заднего прохода .....                                                                                                                    | 404 |
| Тромбофлебит .....                                                                                                                               | 404 |
| Туберкулез лимфатических узлов (желез) .....                                                                                                     | 404 |
| Туберкулез костей и суставов. .... " . ■ .....                                                                                                   | 405 |
| Туберкулез коленного сустава. .... " .....                                                                                                       | 406 |
| Туберкулез позвоночника. .... " .....                                                                                                            | 406 |
| Туберкулез тазобедренного сустава .....                                                                                                          | 406 |
| Туберкулез почки .....                                                                                                                           | 407 |
| Ушиб .....                                                                                                                                       | 407 |
| Ушиб мозга см. <i>Мозга повреждения</i> .....                                                                                                    | 408 |
| Фиброаденома молочной железы .....                                                                                                               | 408 |
| Фиброзные остеоидистрофии .....                                                                                                                  | 408 |
| Фимоз. Парафимоз .....                                                                                                                           | 409 |
| Флегмонл. ....                                                                                                                                   | 410 |
| Фурункул. Чирый .....                                                                                                                            | 410 |
| Фурункул .....                                                                                                                                   | 411 |
| Цистит. Воспаление мочевого пузыря .....                                                                                                         | 412 |
| Шок травматический .....                                                                                                                         | 412 |
| Электротравма .....                                                                                                                              | 413 |
| Эпидидимит. Воспаление придатка яичка .....                                                                                                      | 413 |
| Эписпадия (Отсутствие верхней стенки мочеиспускательного<br>канала) и Гипоспадия (Отсутствие нижней стенки мо<br>чеиспускательного канала) ..... | 413 |
| Эхинококк .....                                                                                                                                  | 414 |
| Эхинококк печени .....                                                                                                                           | 414 |
| Язвы .....                                                                                                                                       | 415 |
| Язва голени варикозная (узловатая) .....                                                                                                         | 415 |
| Язва пептическая .....                                                                                                                           | 415 |
| Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки<br>см. гл. I <i>Внутренние болезни</i> .....                                                 | 416 |
| Языка острое гнойное воспаление .....                                                                                                            | 416 |

|                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Г л а в а VII. Акушерство. Проф. Е. И. Кватер.....                                                                         | 417   |
| Аборт или выкидыш .....                                                                                                    | 417   |
| Асептика и антисептика в акушерстве.....                                                                                   | 419   |
| Асфиксия (удушие, прекращение дыхания) .....                                                                               | 420   |
| Атонические (гипотонические) кровотечения .....                                                                            | 422   |
| Беременность внематочная .....                                                                                             | 423   |
| Водянка. Отек беременных .....                                                                                             | 424   |
| Выпадение мелких частей плода .....                                                                                        | 425   |
| Выпадение пуповины .....                                                                                                   | 425   |
| Двойни .....                                                                                                               | 426   |
| Желтая острая дистрофия печени.....                                                                                        | 428   |
| Задержка лохий .....                                                                                                       | 428   |
| Задержка плаценты или части ее .....                                                                                       | 429   |
| Занос кровяной см. <i>Аборт</i> .....                                                                                      | 430   |
| Занос мясистый см. <i>Аборт</i> .....                                                                                      | 430   |
| Занос пузырный .....                                                                                                       | 430   |
| Неукротимая рвота беременных см. <i>Рвота беременных</i> ....                                                              | 431   |
| Нефропатия беременных.....                                                                                                 | 431   |
| Обвитие пуповины.....                                                                                                      | 431   |
| Обезболивание родов .....                                                                                                  | 432   |
| Обезболивание родов пенхопрофилактическим методом<br>см. <i>Психопрофилактический. М'тод обезболивания<br/>родов</i> ..... | 434   |
| Отек беременных см. <i>Водянка беременных</i> .....                                                                        | 434   |
| Плацентарный полни см. <i>Аборт</i> .....                                                                                  | 434   |
| Поворот плода.....                                                                                                         | 434   |
| Положение плода косое см. <i>Положения плода поперечные<br/>и косые</i> .....                                              | 436   |
| Положения плода поперечные и косые .....                                                                                   | 436   |
| Послеродовой период.....                                                                                                   | 438   |
| Почка беременные см. <i>Нефропатия беременных</i> .....                                                                    | 439   |
| Предлежание детского места — плаценты .....                                                                                | 439   |
| Предложения плода головные неправильные .....                                                                              | 441   |
| Предлежания плода тазовые .....                                                                                            | V 443 |
| Преждевременная отслойка нормально расположенного дет<br>ского места .....                                                 | 445   |
| Преждевременные роды .....                                                                                                 | 445   |
| Преэклампсия см. <i>Эклампсия</i> .....                                                                                    | 446   |
| Психопрофилактический метод обезболивания родов .....                                                                      | 446   |
| Разрыв матки, шейки, промежности .....                                                                                     | 452   |
| Рвота беременных.....                                                                                                      | 453   |
| Роды.....                                                                                                                  | 454   |
| Слабость родовой деятельности.....                                                                                         | 457   |
| Схватки судорожные.....                                                                                                    | 458   |
| Травматизм в родах, профилактика .....                                                                                     | 458   |
| Трещины сосков .....                                                                                                       | 461   |
| Эклампсия, преэклампсия .....                                                                                              | 461   |
| Язвы послеродовые .....                                                                                                    | 464   |
| Д о б а в л е н и е. Календарь для определения сроков дородо<br>вого и послеродового отпуска .....                         | 465   |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Г л а в а VIII. Женские болезни (Гинекология). Проф.<br>Е. И. Кватер .....        | 467 |
| Аднексит. Воспалительное заболевание придатков матки<br>(труб и яичников).....    | 467 |
| Амепоррея. Отсутствие менструаций.....                                            | 468 |
| Атрезия. Заращение влагалища, шейки матки.....                                    | 470 |
| Бели .....                                                                        | 470 |
| Бесплодие .....                                                                   | 472 |
| Вагинит. Кольпит. Воспаление слизистой оболочки вла<br>галища. ....               | 473 |
| Вагинит трихомонадный.....                                                        | 474 |
| Вульвит .....                                                                     | 474 |
| Вульво-вагинит .....                                                              | 475 |
| Вульвы зуд .....                                                                  | 475 |
| Выпадение влагалища см. - <i>Матки и влагалища опущения<br/>и выпадения</i> ..... | 476 |
| Выпадение матки см. <i>Матки и влагалища опущения и выпадения</i> .....           | 476 |
| Гоноррея .....                                                                    | 476 |
| Дисменоррея. Болезненные менструации. ....                                        | 478 |
| Киста яичника.....                                                                | 480 |
| Климактерические расстройства. ....                                               | 480 |
| Кольпит см. <i>Вагинит</i> .....                                                  | 481 |
| Кондиломы острые.....                                                             | 481 |
| Мастит. Грудница. Воспаление грудной железы .....                                 | 481 |
| Матки и влагалища опущения и выпадения .....                                      | 482 |
| Маточные кровотечения.....                                                        | 483 |
| Метрит. Воспаление мышц матки .....                                               | 484 |
| Метроэндометрит см. <i>Эндометрит</i> .....                                       | 485 |
| Миома, фибромиома матки.....                                                      | 485 |
| Недержание, недержание мочи.....                                                  | 483 |
| Опущение влагалища см. <i>Матки и влагалища опущения и выпадения</i> .....        | 487 |
| Опущение матки см. <i>Матки и влагалища опущения и выпадения</i> .....            | 487 |
| Параметрит .....                                                                  | 487 |
| Пельвеперитонит. Воспаление брюшины малого<br>таза .....                          | 487 |
| Перекр'з'чивание ножки опухоли .....                                              | 488 |
| Перитонит см. <i>гл. VI Хирургические болезни</i> .....                           | 488 |
| Пиемия см. <i>Сепсис</i> .....                                                    | 488 |
| Полин матки .....                                                                 | 488 |
| Поясничные боли .....                                                             | 489 |
| Рак матки .....                                                                   | 489 |
| Свищи .....                                                                       | 491 |
| Сепсис см. <i>гл. VI Хирургические болезни</i> .....                              | 492 |
| Тромбофлебитом, <i>гл. VI Хирургические болезни</i> .....                         | 492 |
| Ущемление матки .....                                                             | 492 |
| Эндометрит. Воспаление слизистой оболочки матки .....                             | 492 |
| Эрозия шейки матки .....                                                          | 493 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава IX. Болезни уха, носа и горла. Проф.<br>А. Г. Лихачев .....            | 495 |
| Абсцесс. Нарыв заглоточный .....                                             | 495 |
| Абсцесс заглоточный боковой .....                                            | 495 |
| Абсцесс носовой перегородки см. Гематома носовой перегородки .....           | 496 |
| Абсцесс околоминдаликовый (перитонзиллярный) .....                           | 496 |
| Аденоиды. Гипертрофия глоточной миндалины .....                              | 496 |
| Ангины инфекционные .....                                                    | 497 |
| Ангина катарральная .....                                                    | 497 |
| Ангина лакунарная .....                                                      | 497 |
| Ангина фолликулярная .....                                                   | 498 |
| Ангина Людовика .....                                                        | 498 |
| Ангина язвенно-плеччатая .....                                               | 498 |
| Воспаление придаточных пазух носа, острое и хроническое ..                   | 499 |
| Воспаление среднего уха, острое .....                                        | 501 |
| Воспаление среднего уха хроническое гнойное .....                            | 502 |
| Гайморит см. Воспаление придаточных пазух носа .....                         | 502 |
| Гематома (кровенная опухоль) носовой перегородки .....                       | 502 |
| Гипертрофия глоточной миндалины см. Аденоиды .....                           | 502 |
| Гипертрофия небных миндалин .....                                            | 502 |
| Глухонмота .....                                                             | 502 |
| Дифтерия гортани см. Круп гортанный истинный .....                           | 503 |
| Инородные тела гортани и бронхов .....                                       | 503 |
| Инородные тела носа .....                                                    | 503 |
| Инородные тела уха .....                                                     | 504 |
| Искривление носовой перегородки .....                                        | 504 |
| Кровотечение носовое .....                                                   | 504 |
| Круп гортанный истинный. Дифтерия гортани .....                              | 504 |
| Круп гортанный ложный. Подсвязочное острое воспаление гортани .....          | 505 |
| Лабиринтит .....                                                             | 505 |
| Ларингит острый. Воспаление гортани .....                                    | 505 |
| Ларингит хронический. .... *                                                 | 505 |
| Мастоидит острый. Воспаление сосцевидного отростка .....                     | 506 |
| Меньера болезнь .....                                                        | 506 |
| Насморк атрофический .....                                                   | 507 |
| Насморк вазомоторный (сосудодвигательный) или невrogenный рефлекторный ..... | 507 |
| Насморк зловонный (озена) .....                                              | 508 |
| Насморк острый .....                                                         | 508 |
| Насморк хронический .....                                                    | 509 |
| Нерва слухового (улитковой ветви) воспаление, невриты ..                     | 509 |
| Озена см. Насморк зловонный .....                                            | 510 |
| Опухоли гортани .....                                                        | 510 |
| Опухоли злокачественные гортани см. Рак гортани .....                        | 510 |
| Опухоли злокачественные носа (рак, саркома) .....                            | 510 |
| Отит см. Воспаление среднего уха .....                                       | 510 |
| Отосклероз .....                                                             | 510 |
| Параличи гортанных мышц .....                                                | 511 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Перихондрит гортанных хрящей .....                                                       | 511 |
| Повреждения гортани .....                                                                | 511 |
| Повреждения носа и его придаточных пазух .....                                           | 512 |
| Повреждения уха .....                                                                    | 512 |
| Полипы носа .....                                                                        | 512 |
| Полипы уха .....                                                                         | 513 |
| Рак гортани .....                                                                        | 513 |
| Риносклерома см. Склерома гортани .....                                                  | 513 |
| Сепсис отогенный. Сепсис ушного происхождения .....                                      | 513 |
| Серная пробка .....                                                                      | 514 |
| Склерома гортани- .....                                                                  | 514 |
| Тонзиллит. Воспаление, миндалин хроническое .....                                        | 514 |
| Туберкулез гортани .....                                                                 | 514 |
| Фарингит .....                                                                           | 515 |
| Фронтит см. Воспаление придаточных пазух носа .....                                      | 516 |
| Фурункул (чирпй) наружного слухового прохода .....                                       | 516 |
| Фурункул носа .....                                                                      | 516 |
| Глава X. Глазные болезни. Проф. З. А. Павлова-Камин<br>ская и доцент А. В. Коленко ..... | 517 |
| Авитаминоз А .....                                                                       | 517 |
| Анестезия в глазной практике .....                                                       | 517 |
| Бленоррея см. Гонобленоррея. .... *                                                      | 517 |
| Блефарит сухой. Воспаление краев век сухое. ....                                         | 517 |
| Блефарит язвенный .....                                                                  | 518 |
| Близорукость .....                                                                       | 518 |
| Воспаление зрительного нерва .....                                                       | 518 |
| Воспаление радужной оболочки .....                                                       | 519 |
| Воспаление сетчатки .....                                                                | 520 |
| Воспаление слезного мешка .....                                                          | 520 |
| Выворот век .....                                                                        | 520 |
| Глазная повязка .....                                                                    | 521 |
| Глаукома .....                                                                           | 521 |
| Глаукома вторичная .....                                                                 | 522 |
| Глиома сетчатки .....                                                                    | 522 |
| Гонобленоррея .....                                                                      | 523 |
| Градина .....                                                                            | 523 |
| Дальнозоркость .....                                                                     | 524 |
| Дальнозоркость старческая .....                                                          | 524 |
| Застой соска зрительного нерва .....                                                     | 524 |
| Злокачественные новообразования .....                                                    | 524 |
| Исследование глаз .....                                                                  | 525 |
| Катаракта. Помутнение хрусталика .....                                                   | 525 |
| Кератит паренхиматозный .....                                                            | 526 |
| Кератоконъюнктивит скрофулезкий .....                                                    | 527 |
| Конъюнктивит дифтерийный .....                                                           | 528 |
| Конъюнктивит острый, инфекционный. Воспаление слизистой оболочки глаз .....              | 528 |
| Конъюнктивит фолликулярный .....                                                         | 528 |
| Конъюнктивит хронический .....                                                           | 529 |
| Косоглазие .....                                                                         | 529 |



|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Кровоизлияние под конъюнктиву .....                               | 530 |
| Крыловидная плева .....                                           | 530 |
| Куриная слепота см. <i>Авитаминоз А</i> .....                     | 530 |
| Ожоги глаз лучистой энергией .....                                | 530 |
| Ожоги глаз термические .....                                      | 530 |
| Ожоги глаз химические и ОВ .....                                  | 531 |
| Опушение верхнего века .....                                      | 531 |
| Осмотр глаз у детей .....                                         | 531 |
| Офтальмия симпатическая см. <i>Симпатическое воспаление</i> . . . | 531 |
| Офтальмия электрическая см. <i>Ожоги лучистой энергией</i> . . .  | 531 |
| Очки .....                                                        | 531 |
| Панофтальмит .....                                                | 531 |
| Повреждения глаз механические .....                               | 532 |
| Протез глазной .....                                              | 532 |
| Ранение глаза прободное .....                                     | 533 |
| Симпатическая офтальмия. Симпатическое воспаление глаз . .        | 533 |
| Трахома. Хроническое инфекционное воспаление конъюнктив           |     |
| ктивы .....                                                       | 534 |
| Флегмона орбиты .....                                             | 535 |
| Язва роговицы .....                                               | 535 |
| Язва роговицы ползучая .....                                      | 535 |
| Ячмень .....                                                      | 536 |
| Г л а в а XI. Кожные болезни. Доцент <i>Е. Я. Хесин</i> .....     | 537 |
| Аденома .....                                                     | 537 |
| Атрофия кожи .....                                                | 537 |
| Баланит. Баланопостит .....                                       | 537 |
| Болезнь Дюринга .....                                             | 537 |
| Бородавки .....                                                   | 538 |
| Бородавчатый туберкулез кожи. см. <i>Туберкулез кожи</i> . . .    | 538 |
| Веснушки. ' .....                                                 | 538 |
| Волосатость .....                                                 | 539 |
| Волчанка см. <i>Туберкулез кожи</i> .....                         | 539 |
| Волчанка красная .....                                            | 539 |
| Вшивость .....                                                    | 539 |
| Дерматит. Воспаление кожи .....                                   | 540 |
| Дисгидроз. Водяница .....                                         | 541 |
| Зуд кожи .....                                                    | 541 |
| Импетиго заразное см. <i>Пиодермия</i> .....                      | 542 |
| Импетиго простое см. <i>Пиодермия</i> .....                       | 542 |
| Ихтиоз. Рыбья чешуя .....                                         | 542 |
| Крапивница .....                                                  | 542 |
| Лишай красный плоский .....                                       | 543 |
| Лишай опоясывающий .....                                          | 543 |
| Лишай отрубевидный или разноцветный .....                         | 544 |
| Лишай пузырьковый .....                                           | 544 |
| Лишай розовый .....                                               | 544 |
| Лишай стригущий .....                                             | 545 |
| Лишай чешуйчатый .....                                            | 546 |
| Микроспория .....                                                 | 547 |
| Моллюск заразительный .....                                       | 547 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Ознобление .....                                                 | 547 |
| Онихомикоз .....                                                 | 547 |
| Опрелость .....                                                  | 548 |
| Папуло-иокротический туберкулез см. <i>Туберкулез кожи</i> ..... | 548 |
| Парша .....                                                      | 548 |
| Пиодермия .....                                                  | 549 |
| Песь .....                                                       | 549 |
| Плешивость .....                                                 | 550 |
| Потливость .....                                                 | 550 |
| Потница .....                                                    | 551 |
| Почесуха .....                                                   | 551 |
| Проказа .....                                                    | 551 |
| Пузырчатка. .... *                                               | 551 |
| Пятна родимые. Родинки .....                                     | 552 |
| Рак кожный .....                                                 | 552 |
| Рыбья чешуя см. <i>Ихтиоз</i> . . '                              | 552 |
| Себоррея .....                                                   | 552 |
| Сикоз .....                                                      | 553 |
| Склеродермия .....                                               | 553 |
| Скрофулодерма см. <i>Туберкулез кожи</i> .....                   | 554 |
| Туберкулез кожи .....                                            | 554 |
| Трихофития см. <i>Лишай стригущий</i> .....                      | 555 |
| Угри простые .....                                               | 555 |
| Угри белые .....                                                 | 556 |
| Угри черные .....                                                | 556 |
| Фолликулит .....                                                 | 556 |
| Чесотка .....                                                    | 556 |
| Экзема .....                                                     | 557 |
| Эктима см. <i>Пиодермия</i> .....                                | 539 |
| Эпидермофития .....                                              | 559 |
| Эритема многоформная экссудативная .....                         | 560 |
| Эритема узловатая .....                                          | 560 |
| Эритразма .....                                                  | 560 |
| Язвенный туберкулез кожи см. <i>Туберкулез кожи</i> .....        | 560 |
| Г л а в а XII. Венерические болезни. Проф. <i>В. Я. Ару</i>      |     |
| тюнов и доцент <i>Е. Я. Хесин</i> . . .                          | 561 |
| Гоноррея. Триппер .....                                          | 561 |
| Лимфогрануломатоз паховый см. <i>Четвертая венерическая бо</i>   |     |
| лезнь .....                                                      | 563 |
| Мягкий шанкр. .... *                                             | 563 |
| Сифилис .....                                                    | 565 |
| Твердый шанкр см. <i>Сифилис</i> . . .                           | 580 |
| Четвертая венерическая болезнь .....                             | 580 |
| Г л а в а XIII. Заболевания зубов п полости рта. Проф.           |     |
| <i>И. Г. Лукомский</i> .....                                     | 581 |
| Альвеолярная пиоррея. Пародонтоз. Амфодонтоз .....               | 581 |
| Боль запломбированного зуба .....                                | 582 |
| Гингивит см. <i>Стоматит</i> .....                               | 583 |
| Запах изо рта см. <i>Стоматит, лечение</i> .....                 | 583 |

|                                                                                    |                                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 892                                                                                | Зубная боль см. <i>Периодонтит. Пульпит.</i> .....                          | 583 |
|                                                                                    | Зубной камень .....                                                         | 583 |
|                                                                                    | Кариес зуба .....                                                           | 584 |
|                                                                                    | Нома см. <i>Стоматит язвенный</i> .....                                     | 585 |
|                                                                                    | Остеомиелит челюсти .....                                                   | 585 |
|                                                                                    | Переломы челюсти .....                                                      | 585 |
|                                                                                    | Периодонтит. Перицементит .....                                             | Г87 |
|                                                                                    | Прорезывание зубов .....                                                    | 589 |
|                                                                                    | Пульпит .....                                                               | 590 |
|                                                                                    | Пульпит острый .....                                                        | 590 |
|                                                                                    | Пульпит хронический .....                                                   | 590 |
|                                                                                    | Пульпы гангрена .....                                                       | 590 |
|                                                                                    | Стоматиты .....                                                             | 591 |
|                                                                                    | Уход за полостью рта больного .....                                         | 597 |
|                                                                                    | Экстракция зубов .....                                                      | 598 |
| Г л а в а XIV. Медицинская техника. Кандидат медицинских наук В. И. Кристман ..... |                                                                             |     |
|                                                                                    | Аутогемотерапия .....                                                       | С04 |
|                                                                                    | Банки Вира .....                                                            | 604 |
|                                                                                    | Банки сухие .....                                                           | 604 |
|                                                                                    | Биопсия .....                                                               | 605 |
|                                                                                    | Бужирование .....                                                           | 605 |
|                                                                                    | Ванны водяные .....                                                         | 606 |
|                                                                                    | Ванны лекарственных .....                                                   | 606 |
|                                                                                    | Венепункция .....                                                           | 607 |
|                                                                                    | Венесекция .....                                                            | 608 |
|                                                                                    | Вливания внутривенные .....                                                 | 608 |
|                                                                                    | Вливания подкожные .....                                                    | 609 |
|                                                                                    | Впрыскивания (инъекции) внутривенные см. <i>Вливания внутривенные</i> ..... | 609 |
|                                                                                    | Впрыскивания (инъекции) внутрикожные .....                                  | 609 |
|                                                                                    | Впрыскивания (инъекции) внутримышечные .....                                | 609 |
|                                                                                    | Впрыскивания (инъекции) подкожные .....                                     | 609 |
|                                                                                    | Втирания .....                                                              | 611 |
|                                                                                    | Газоотведение .....                                                         | 611 |
|                                                                                    | Горчичники .....                                                            | 612 |
|                                                                                    | Грелки .....                                                                | 612 |
|                                                                                    | Дыхание искусственное см. <i>Искусственное дыхание</i> .....                | 612 |
|                                                                                    | Желудка промывание см. <i>Промывание желудка</i> .....                      | 612 |
|                                                                                    | Желудочного сока извлечение см. <i>Зондирование желудка</i> .....           | 612 |
|                                                                                    | Зондирование двенадцатиперстной кишки тонким зондом .....                   | 613 |
|                                                                                    | Зондирование желудка толстым зондом .....                                   | 613 |
|                                                                                    | Зондирование желудка тонким зондом .....                                    | 614 |
|                                                                                    | Ингаляция .....                                                             | 615 |
|                                                                                    | Интубация .....                                                             | 615 |
|                                                                                    | Инъекция см. <i>Впрыскивания</i> .....                                      | 616 |
|                                                                                    | Искусственное дыхание .....                                                 | 616 |
|                                                                                    | Катетеризация .....                                                         | 618 |
|                                                                                    | Клизма .....                                                                | 618 |
|                                                                                    | Компресс согревающий .....                                                  | 622 |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Компресс спиртовой (водочный) .....                                                                                   | 622 |
| Кровопускание см. <i>Венепункция. Венесекция</i> .....                                                                | 622 |
| Лед .....                                                                                                             | 622 |
| Мочевое пузыря промывание см. <i>Промывание мочевого пузыря</i> .....                                                 | 623 |
| Мушка .....                                                                                                           | 623 |
| Мытье рук .....                                                                                                       | 623 |
| Обеззараживание (стерилизация) .....                                                                                  | 624 |
| Обертывание .....                                                                                                     | 625 |
| Переливание крови .....                                                                                               | 626 |
| Перчатки .....                                                                                                        | 628 |
| Питание искусственное .....                                                                                           | 629 |
| Пиявки .....                                                                                                          | 629 |
| Плевральной жидкости выпускание см. <i>Прикол плевры</i> .....                                                        | 630 |
| Повязки .....                                                                                                         | 630 |
| Пробные завтраки см. <i>Зондирование желудка</i> .....                                                                | 633 |
| Прокол брюшной полости .....                                                                                          | 633 |
| Прокол плевры .....                                                                                                   | 633 |
| Промывание желудка .....                                                                                              | 634 |
| Промывание мочевого пузыря .....                                                                                      | 634 |
| Согревающий компресс см. <i>Компресс согревающий</i> .....                                                            | 635 |
| Спиртовой компресс см. <i>Компресс спиртовой</i> .....                                                                | 635 |
| Спринцевание влагалища .....                                                                                          | 635 |
| Стерилизация см. <i>Обеззараживание</i> .....                                                                         | 635 |
| Фрикции .....                                                                                                         | 635 |
| Г л а в а XV. Простейшие лабораторные исследования. Кандидат медицинских наук В. И. Кристман .....                    |     |
| Исследование крови .....                                                                                              | 636 |
| Исследование мочи .....                                                                                               | 642 |
| Исследование желудочного содержимого .....                                                                            | 646 |
| Исследование кала .....                                                                                               | 649 |
| Исследование мокроты .....                                                                                            | 651 |
| Исследование налетов .....                                                                                            | 653 |
| Исследование отделяемого из половых органов .....                                                                     | 654 |
| Г л а в а XVI. Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях. Кандидат медицинских наук В. И. Кристман ..... |     |
| Замерзание .....                                                                                                      | 655 |
| Засыпанные землей см. <i>Землей засыпанные</i> .....                                                                  | 655 |
| Землей засыпанные .....                                                                                               | 655 |
| Молнией поражение .....                                                                                               | 656 |
| Обморок .....                                                                                                         | 656 |
| Повешение .....                                                                                                       | 657 |
| Поражение молнией см. <i>Молнией поражение</i> .....                                                                  | 657 |
| Поражение электрическим током см. <i>Электрическим током поражение</i> .....                                          | 657 |
| Солнечный удар .....                                                                                                  | 657 |
| Тепловой удар .....                                                                                                   | 657 |
| Удушье .....                                                                                                          | 658 |

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Укусы змей .....                                                                                   | 653 |
| Укусы насекомых .....                                                                              | 658 |
| Укусы пчел (ос, шмелей и других) .....                                                             | 659 |
| Утопление .....                                                                                    | 659 |
| Электрическим током поражение .....                                                                | 660 |
| Отравления .....                                                                                   | 660 |
| Первая помощь при острых отравлениях, ядами не опознанными до прибытия врача .....                 | 663 |
| Таблица противоядий и пособий при отравлениях .....                                                | 664 |
| Г л а в а XVII. Фармакологические сведения. Проф.                                                  |     |
| <i>Я. Х. Нолле</i> .....                                                                           | 701 |
| О прописывании рецептов врачами .....                                                              | 704 |
| Правила выписки лекарств фельдшерами и акушерками . . .                                            | 705 |
| Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих лекарств для взрослых .....            | 706 |
| Дозировка наиболее часто применяемых в детском возрасте лекарств .....                             | 710 |
| Краткая таблица о несовместимых лекарственных смесях . . .                                         | 727 |
| Лекарственные вещества, применяемые при острых отравлениях .....                                   | 728 |
| Дозировки лекарственных веществ для подкожных и внутримышечных инъекций детям (разовая доза) ..... | 731 |
| Антибиотики .....                                                                                  | 732 |
| Грамицидин С .....                                                                                 | 732 |
| Пенициллин .....                                                                                   | 733 |
| Стрептомицин .....                                                                                 | 738 |
| Эритроин .....                                                                                     | 739 |
| Экмолин .....                                                                                      | 741 |
| Альбомуцин .....                                                                                   | 741 |
| Лизоцим .....                                                                                      | 742 |
| Левомецитин (хлоромецитин) .....                                                                   | 743 |
| Фитонциды .....                                                                                    | 744 |
| Лечебные сыворотки. • .....                                                                        | 745 |
| Противоботулиническая сыворотка .....                                                              | 746 |
| Противодифтерийная сыворотка .....                                                                 | 747 |
| Противодизентерийная сыворотка .....                                                               | 747 |
| Сыворотки против газовой гангрены .....                                                            | 747 |
| Противопневмококковая сыворотка .....                                                              | 748 |
| Противоскарлатинозная антитоксическая сыворотка . . .                                              | 748 |
| Противостолбнячная сыворотка .....                                                                 | 748 |
| Противостафилококковая антитоксическая сыворотка . . .                                             | 749 |
| Вакцины (по Фармакопее, издание VIII 1952 г.) .....                                                | 749 |
| Бруцеллезная вакцина .....                                                                         | 752 |
| Холерная вакцина .....                                                                             | 752 |
| Жидкая дизентерийная вакцина .....                                                                 | 752 |
| Сухая дизентерийная вакцина в таблетках .....                                                      | 752 |
| Гонококковая вакцина .....                                                                         | 753 |
| Менингококковая вакцина .....                                                                      | 753 |
| Коклюшная вакцина .....                                                                            | 753 |
| Чумная вакцина .....                                                                               | 753 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Антирабическая вакцина (вакцина против бешенства) . . .               | 754 |
| Комбинированная скарлатинозная вакцина .....                          | 754 |
| Стафилококковая вакцина .....                                         | 754 |
| Стрептококковая поливалентная вакцина .....                           | 755 |
| Туберкулезная вакцина БЦЖ .....                                       | 755 |
| Туляремийная вакцина .....                                            | 755 |
| Тетравакцина (тиф, паратиф А и Б и холера). . .                       | 756 |
| Дивакцина (тиф и холера) .....                                        | 756 |
| Тривакцина (тиф и паратиф А и Б) . . .                                | 756 |
| Дивакцина (тиф и паратиф Б) .....                                     | 756 |
| Оспенный дотрип-1 .....                                               | 757 |
| Пентавакцина .....                                                    | 757 |
| Поливакцина .....                                                     | 757 |
| Дизентерийный бактериофаг .....                                       | 758 |
| Сульфаниламидные препараты (сульфамидные препараты, сульфамиды) . . . | 758 |
| Новые лекарственные средства .....                                    | 765 |
| Бигумадь .....                                                        | 765 |
| Дибазол .....                                                         | 766 |
| Дикумарин .....                                                       | 767 |
| Димедрол .....                                                        | 767 |
| Дифенш .....                                                          | 768 |
| Пириминосалициловая кислота (ПАСК) .....                              | 768 |
| Теофедрин .....                                                       | 769 |
| Фенадон .....                                                         | 769 |
| Фурамон .....                                                         | 770 |
| Триметин .....                                                        | 770 |
| Пеллоидодестиллат .....                                               | 770 |
| Неувен .....                                                          | 771 |
| Синтомицин .....                                                      | 771 |
| Пеллоидин .....                                                       | 772 |
| Г л а в а XVIII. Рецептурный справочник. Проф.                        |     |
| <i>Я. Х. Нолле</i> ' .....                                            | 773 |
| Адсорбирующие средства .....                                          | 773 |
| Антисептические и дезинфицирующие средства .....                      | 773 |
| Болеутоляющие, обезболивающие и противоспазматические средства .....  | 780 |
| Возбуждающие средства .....                                           | 782 |
| Вязущие средства .....                                                | 783 |
| Жаропонижающие средства . . . . .                                     | 787 |
| Желудочно-кишечные средства .....                                     | 788 |
| Желчегонные средства .....                                            | 792 |
| Кровоостанавливающие средства .....                                   | 793 |
| Маточные средства .....                                               | 794 |
| Местноанестезирующие средства .....                                   | 795 |
| Мочегонные средства .....                                             | 796 |
| Наркотические средства .....                                          | 797 |
| Отхаркивающие средства .....                                          | 798 |
| Противокашлевые средства .....                                        | 799 |
| Антисептики легких .....                                              | 800 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Прижигающие средства.....                                            | 800 |
| Потогонные средства.....                                             | 800 |
| Противоаномические средства.....                                     | 801 |
| Противогонорройные средства.....                                     | 802 |
| Противогеморроидальные средства.....                                 | 803 |
| Противоглистные средства.....                                        | 803 |
| Противомални-ийАше средства.....                                     | 804 |
| Противопаразитарные и инсектицидные (против насекомых) средства..... | 80В |
| Противоподагрические средства.....                                   | 807 |
| Противорвотные и противотсшнотные средства.....                      | 807 |
| Противосифилитические средства.....                                  | 808 |
| Противоспазматические средства.....                                  | 809 |
| Противоядия.....                                                     | 811 |
| Раздражающие кожу средства.....                                      | 811 |
| Расшряющие зрачок средства.....                                      | 812 |
| Рвотные средства.....                                                | 812 |
| Сердечные и сосудосуживающие средства.....                           | 812 |
| Слабительные средства см. Жел\дошно-}.ишечные средства.....          | 815 |
| Слизистые и обволакивающие средства.....                             | 815 |
| Снотворные средства.....                                             | 815 |
| Сосудорасширяющие средства.....                                      | 817 |
| Суживающие зрачок средства.....                                      | 818 |
| Укрепляющие и действующие на обмен веществ средства.....             | 818 |
| Успокаивающие нервную систему средства.....                          | 820 |
| Этиотропные или химиотерапевтические средства.....                   | 821 |
| Органе- и гормонопрепараты.....                                      | 823 |
| Витаминные препараты.....                                            | 825 |
| Белковые препараты (для протеинотерапии).....                        | 826 |
| Препараты для диагностики.....                                       | 827 |
| Кровезаменители.....                                                 | 827 |
| Объяснения сокращений в рецептах.....                                | 828 |
| Стандартные рецепты (готовые лекарственные средства).....            | 831 |
| Предметный указатель.....                                            | 846 |

**37 руб.**

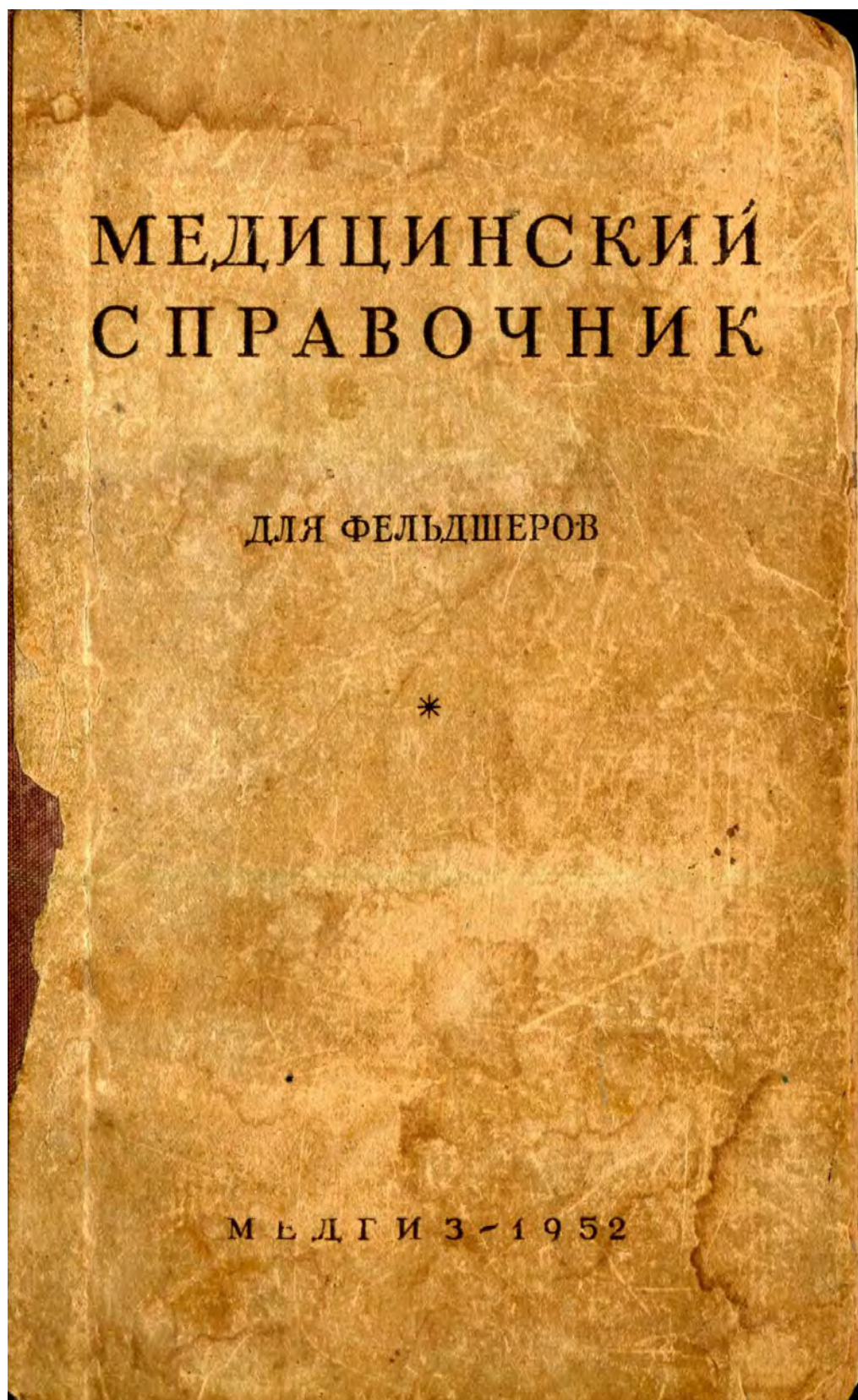
Редактор Г. И. ЖУКОВ  
Технический редактор Н. П. Карл гак  
Зав. корректурой Л. М. Голицына  
Переплет художника К. М. Егорова

Т06184. Подписано к печати 17/X 1952г. МС-09, Ф. 6. 84XЮ8<sup>1</sup>/a>=14 бум. л.—  
45,92 ц. л. 72,25 уч.-изд. л. 63000 зп. в 1 п. л. Тирада 100 000 экз.  
Цена 36 руб. Переплет 1 руб. (По преискуранту 1952 г.) Заказ 3563.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова ГлавполиграфйВдата  
при Совете Министров СССР. МОСКВАРР, Валовая, 28

37 руб.

kodbök Aibolem bArI/Onleg ComposarC ibANKNATOPRAD



# МЕДИЦИНСКИЙ СПРАВОЧНИК

ДЛЯ АЭФЕЛЬДВЕДРАВ\*

q



# МЕДИЦИНСКИЙ СПРАВОЧНИК

ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. Н. В.  
КОЛЕСНИКОВ И  
БАРДАВЕЛИДЗЕ Н. Т.

и доктора медицинских наук

А. Н. ШАБАНОВА

*Издание четвертое,  
переработанное и дополненное*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ •  
МЕДГИЗ - 1952 - МОСКВА



СОСТАВИТЕЛЬ СПРАВОЧНИКА Проф.

Н. В. КОЛЕСНИКОВ И.

БАРДАВЕЛИДЗЕ Н. Т.

В РАБОТЕ НАД КНИГОЙ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ  
СЛЕДУЮЩИЕ АВТОРЫ:

Проф. М. Б. Александров,

проф. В. Я. Арутюнов,

доктор медицинских наук И. М. Беркович,

проф. А. Н. Великорецкий,

кандидат медицинских наук Р. Л. Гамбург,

кандидат медицин- ских наук С. Г. Звягинцева,

кандидат медицинских наук А. М. Ивенская,

проф. З. А. Каминская Павлова,

проф. Е. И. Кватор,

доктор медицинских наук А. Б. Коленько,

канди дат медицинских наук М. Б. Коссюра,

доктор медицинских наук Э. М. Кравси,

кандидат медицинских наук В. И. Кристман.

доцент В. А. Кружков, проф. А. Г. Лихачев,

проф. И. 1. Луком ский, проф. Я. Х. Нолле,

доктор медицинских наук Е. Н. Мануилов,

проф. А. С. Розенталь, проф. М. Я. Серейский,

кандидат медицин- ских наук М. Я. Турепкий,

доцент Е. Я. Хосин,

кандидат медицин ских наук Х. Л. Эмдина ■

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Прогресс медицинской науки, совершенствование методов лечения болезней, открытие новых лекарственных средств, внедрение в практическую медицину физиологического учения акад. И. П. Павлова, на основе которого создаются более правильные представления о всех физиологических и патологических процессах, происходящих в организме человека, обязывает нас весьма внимательно подойти К выпуску в свет четвертого издания «Медицинского справочника для фельдшеров».

Многочисленные письма читателей, их критические замечания и пожелания помогают в нашей работе. Огромный спрос на эту книгу, несмотря на то, что третье издание было выпущено тиражом в 100 000 экземпляров, обязывает нас удовлетворить потребность в ней периферийных медицинских работников.

В настоящем, четвертом, издании «Медицинский справочник для фельдшеров» был подвергнут новому серьезному пересмотру с учетом критических замечаний, опубликованных в печати, и писем читателей, полученных редакцией. Была выявлена необходимость внести существенные поправки, изменения, дополнения не только при описании отдельных болезненных форм, но даже целые главы написать заново.

Глава «Внутренние болезни» была подвергнута значительной переработке. Заново написаны тексты к словам «Анемия», «Болезнь Боткина», «Гипертоническая болезнь», «Неврозы сердца», «Эндокардиты» и др. Глава пополнена описанием новых болезненных форм, некоторых синдромов, медицинских понятий и терминов, часто встречающихся в медицинской практике, но не вошедших в предыдущие издания: «Авитаминозы», «Анурия», «Аритмии», «Ахлия желудка», «Высотная болезнь», «Желтуха», «Легочное сердце», «Лейкоцитоз», «Лейкопения», «Лимфогранулематоз», «Морская болезнь», «Неврозы желудка и кишечника», «Пневмосклероз», «Пароксизмальная тахикардия» и др.

Пересмотрены и дополнены рецептурные прописи, изъяты некоторые вышедшие из употребления лекарственные средства и указаны новые средства, вошедшие в медицинскую практику.

В главе «Хирургические болезни», как и в других главах, вопросы этиологии и патогенеза авторы стремились показать с позиций целостности организма и единства его с окружающей средой. Переработано описание ряда болезненных форм: «Шок травматический», «Ожоги», «Отморожения», «Абсцесс» (лечение), «Фурункулез» (лечение) и др. Учитывались замечания читателей, а также опыт Великой Отечественной войны и опыт применения антибиотиков. Добавлены новые слова: «Абсцесс аппендикулярный», «Ангиома», «Водянка яичка», «Гемартроз», «Гигрома», «Дивертикул пищевода», «Инородные

тела дыхательных путей, мягких тканей, пищевода и прямой кишки», «Мастит хронический (мастопатия)», «Сколиоз», «Травматическая асфиксия», «Электротравма» и др.

В главах «Акушерство» и «Женские болезни» большинство заболеваний написано заново. Весь текст подвергся тщательной переработке. Написаны по просьбе читателей и включены в текст новые болезненные формы: «Роды» (нормальные), «Задержка плаценты или части ее», «Психопрофилактический метод обезболивания родов», «Травматизм в родах». Пересмотрено описание, внесены изменения и дополнения в следующие заболевания: «Аборт», «Асептика и антисептика в акушерстве», «Беременность внематочная», «Климатерические расстройства» и др. Даны новые прописи лекарств.

В главу «Детские болезни» включены описания новых заболеваний. Значительно переделаны описания болезней: «Астма бронхиальная», «Диатез невропатический», «Диатез экссудативный», «Пилороспазм» и др. В отдельных местах внесены изменения как с точки зрения указаний на новые методы лечения, новые препараты, применения антибиотиков, так и указаний на новые позиции в трактовке симптомов и оценке методов лечения. Фиксируется внимание на роли внешней среды и воздействия на нервную систему.

В разделе «Нервные болезни» радикально изменены основные представления о соотношении возбуждимо-тормозных процессов коры мозга. Пересмотрено и значительно дополнено описание отдельных болезненных форм, включены представления о гипертоническом инсульте, туберкулезном менингите, введены указания на лечение стрептококком и ПАСК. Внесены дополнения в описание течения полиомиелита и лечение его прозерпином и дибазолом. Включены новые болезненные формы: «Артериосклероз головного мозга», «Икота», «Миелиит инфекционный», «Паразиты мозга», «Паралич дрожательный», «Сифилис нервной системы», «Хромота перемежающаяся» и др. Значительно дополнено описание кожевниковской эпилепсии. Гвоздено указание на лечение эпилепсии дилапином и по методу доктора Е. П. Кармановой. Произведены исправления, дополнения почти во всех описаниях болезней и их лечении. Сделаны указания на лечение полиневритов тканевой терапией, хореи и каувагии — сном, миопатии — инсулином. Внесены указания в раздел лечебной физкультуры и пополнено количество рецептов.

В целях лучшего понимания читателями отдельных вопросов учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности, изложенных во многих местах справочника, в главе «Психические болезни» введено описание «Общих понятий физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности». Данные указания относятся не только к словам «Нервные болезни» и «Психические болезни», но и ко всем другим, где описываются болезненные формы и их лечение; они имеют общее значение. Поэтому мы рекомендуем читателям познакомиться с ними независимо от того, каких больных они в данный момент наблюдают, так как здесь имеются краткие объяснения терминов: первая и вторая сигнальная система, возбуждение и торможение, понятие иррадиации, концентрации, индукции, типы высшей нервной деятельности.

>

В главе «Психические заболевания» добавлены описания ряда болезненных форм, которые отсутствовали в первых трех изданиях справочника: «Прогрессивный паралич», «Шизофрения», «Реактивные психозы», «Ипохондрия», «Олигофрения», и даны указания о лечении сном. Для всех заболеваний даны характеристики в духе концепций И. П. Павлова. Вся глава написана заново.

В главе «Кожные болезни» отмечается роль нервной системы в возникновении и течении ряда заболеваний кожи и особенно экземы. Глава дополнена описанием таких заболеваний, как «Атрофия кожи», «Песь», «Склеродермия». Дополнено лечение отдельных кожных болезней новыми средствами и методами лечения: жидкостью Гордеева, тканевой терапией по методу Румянцева и др.

В главе «Венерические болезни» составлены заново описания лечения гонореи и сифилиса. Они представлены в соответствии с последними решениями пленума ученой комиссии при отделе по борьбе с кожно-венерическими заболеваниями Министерства здравоохранения СССР. При описании сифилиса и мягкого шанкра и их лечения расширена клиническая часть. Внесены текстовые исправления, введены новые схемы лечения детей и взрослых пенициллином.

Глава «Болезни зубов и полости рта» также подверглась исправлениям, и в нее внесены добавления: «Боль запломбированного зуба», «Уход за зубами», «Уход за полостью рта больного», «Незаконченная экстракция».

В главы «Фармакологические сведения» и «Рецептурный справочник» введены описания новых антибиотиков, фитонцидов и новых лекарственных средств, утвержденных Ученым медицинским советом Министерства здравоохранения СССР и Фармакопейным комитетом. Даны сведения о «Сборах трав» и новые рецепты. Дозировки всех лекарственных средств выправлены по данным дополнительного восьмого издания Фармакопеи СССР, 1952 г.

Проф. Н. В. Колесников

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

После выхода в свет в 1948 г. первого издания «Медицинского справочника для фельдшеров», выпущенного тиражом в 60 000 экземпляров, выявился огромный спрос на эту книгу. Медицинское издательство и редакция получили большое количество писем с просьбой о высылке книги. Для быстрого удовлетворения хотя бы частично потребности медицинских работников в этой книге Медицинское издательство выпустило в свет в 1949 г. второе, стереотипное, издание тиражом в 100 000 экземпляров.

В настоящем, третьем, издании «Медицинский справочник для фельдшеров» был подвергнут значительному пересмотру, исправлениям и дополнениям.

В главе «Внутренние болезни» увеличены рецептурные прописи. Включены дополнения к описаниям форм, болезней, а также новые болезненные состояния, даны в соответствующих местах объяснения специальных терминов, указано применение сульфаниламидных и других новых отечественных препаратов, приведена методика лечения пенициллином.

В главе «Инфекционные болезни» почти по каждой инфекции добавлен дифференциальный диагноз, внесены некоторые добавления и исправления и более подробно описано лечение.

По просьбе многих читателей включены новые главы: «Таблица химического состава и калорийности пищевых продуктов» и «Таблица содержания витаминов в пищевых продуктах».

В главу «Хирургические болезни» включены новые болезненные состояния. Исправлен и дополнен старый материал в соответствии с пожеланиями читателей и критики, например, о закрытых повреждениях органов брюшной полости, об инородных телах в организме человека и др.

В главу «Сифилис» включены новые данные о применении пенициллина при лечении сифилиса.

В главе «Кожные болезни» сделаны поправки и включены новые болезненные состояния, добавлены новейшие методы лечения некоторых заболеваний, например, лечение туберкулеза кожи витамином D<sub>2</sub>, лечение пиодермии и др.

В главах «Акушерство» и «Женские болезни» переработан и исправлен старый текст, введены новые болезненные состояния и новые прописи рецептов.

Подобного рода исправления и дополнения внесены и в другие главы книги.

В главу «Фармакологические сведения» включены новые статьи об антибиотиках, о лечебных сыворотках, о вакцинах и сульфамидных препаратах с изложением их биологической и химической

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

природы, методов приготовления, хранения, показаний и принципов применения.

В рецептурном справочнике приведены сведения о сокращениях в рецептах и приложен список стандартных рецептов, с которыми приходится иметь дело медицинским работникам в их практической работе.

Авторы стремились отразить в справочнике все современные достижения медицинской науки, довести до читателя все то новое, что имеет ценность для практических медицинских работников.

Редакция приносит глубокую благодарность многочисленным читателям, которые прислали нам свои критические замечания и пожелания и этим помогли сделать третье издание «Медицинского справочника для фельдшеров» более содержательным и полным.

Мы надеемся и впредь, что читатели укажут нам дальнейшие пути улучшения нашей книги.

Проф. Н. В. КОЛЕСНИКОВ И. БАРДАВЕЛИДЗЕ Н. Т.

«

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Уже давно средними медицинскими работниками, особенно теми из них, которые работают на фельдшерских и акушерско-фельдшерских пунктах, высказывалось желание иметь небольшое справочное руководство, которое бы позволило быстро навести нужную справку в области диагностики и лечения той или иной формы болезни.

Ныне это пожелание осуществляется. ■

Предлагаемый вниманию читателей справочник включает в себя основные и наиболее часто встречаемые заболевания, а также сведения по простейшим лабораторным исследованиям, медицинской технике и прописыванию лекарств. По каждому заболеванию приводятся данные, необходимые для постановки диагноза, по оказанию скорой и неотложной помощи и общепринятые методы лечения с учетом разрешаемых фельдшеру самостоятельных манипуляций.

Настоящий справочник ни при каких условиях не может и не должен заменить собой медицинскую монографию, учебник. Наоборот, мы надеемся, что он заставит фельдшера для разрешения возникающих перед ним в практической деятельности вопросов и задач более тщательно и глубоко изучать соответствующую литературу, чтобы быть в состоянии оказывать высококвалифицированную помощь.

Редакция будет благодарна всем читателям, которые сообщат свои замечания и пожелания с целью улучшения справочника<sup>1</sup>.

\* Проф. Н. В.

Колесников

## ГЛАВА I ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

**АБСЦЕСС (ГНОЙНИК) ЛЕГКОГО. ГАНГРЕНА (ОМЕРТВЕНИЕ) ЛЕГКОГО (ABSCESSUS PULMONIS, GANGRAENA PULMONIS).** При абсцессе легкого происходит отграниченный от здоровой ткани гнойный распад легочной ткани, вызываемый преимущественно гноеродными бактериями — стафилококками и стрептококками; при гангрене легкого имеет место гнилостный I распад легочной ткани без заметного отграничения от здоровой ткани, вызываемый гнилостными бактериями.

Чаще всего гнойник, а также гангрена легких развиваются при пневмониях у очень ослабленных, истощенных больных и у стариков. Инородные тела (кусочки пищи, косточки, рвотные массы и др.), попадая в легкие через дыхательные пути, могут вызывать образование абсцесса или гангрену. При различных гнойных заболеваниях: остеомиелитах, гнойных аппендицитах, тромбофлебитах, общем сепсисе, септическом эндокардите, послеродовом сепсисе и т. д., гноеродные бактерии, попадая в легочную ткань с током крови, вызывают образование гнойников, часто множественных мелких.

**Симптомы и течение.** Температура ремиттирующая (послабляющая), часто гектическая (изнурительная), иногда сопровождающаяся ознобами с последующим обильным потоотделением. В крови — лейкоцитоз. При закрытых абсцессах (еще не опорожнившихся) на месте абсцесса — отмечается небольшое притупление, ослабленное дыхание и влажные хрипы вокруг очага. Иногда при постукивании и выслушивании никаких изменений обнаружить не удается.

После опорожнения гнойника через бронх выделяется большое количество гнойной жидкой мокроты с приторным запахом. При гангрене легкого мокрота грязного цвета с резким гнилостным запахом.

# При абсцессе легких мокрота обычно делится на два слоя: верхний — серозный, мутный и нижний — зеленовато-желтый, непрозрачный, содержащий форменные элементы, главным образом гнойные клетки. При гангрене легких — трехслойная мокрота: верхний слой — пенистый, зеленовато-желтого цвета, состоит из слизисто-гнойных комков с пузырьками воздуха; средний слой — мутноватый, серозный, с примесью хлопьев слизи; нижний — мутный, зеленовато-желтого цвета, с большим количеством гноя.

В мокроте при исследовании обнаруживают эластические волокна (продукт распада легочной ткани) и обрывки легочной ткани (при гангрене).

Образовавшаяся в легких полость дает тимпанический звук (если полость значительна по своим размерам) — при аускультации же отмечается бронхиальное или амфорическое дыхание а вокруг полости — влажные хрипы.

После опорожнения абсцесса полость может в течение нескольких недель постепенно зарубцеваться и наступить полное выздоровление.

Иногда болезнь переходит в хроническую форму: температура надает, может быть даже нормальной, но бо'льшой продолжает выделять большие количества мокроты с запахом; при этом продолжается общая интоксикация от всасывания в кровь продуктов распада, развивается значительное малокровие, общая слабость, потеря аппетита, последующее истощение организма; пальцы принимают вид «барабанных палочек». Последнее является плохим прогностическим признаком, так как этот симптом указывает на значительные трофические изменения во всем организме вследствие длительной общей интоксикации.

Вследствие разрушения некротическим процессом кровепос-пых сосудов могут быть кровотечения. Поверхностно расположенный абсцесс может прорваться в плевру и вызвать пиопневмо-торакс.

Как тяжелое осложнение общей интоксикации при хроническом течении болезни может развиваться амилоидоз внутренних органов, в том числе и амилоидно-липидный нефроз. В таком состоянии больные погибают от общего истощения или присоединившихся осложнений.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Невскрывшийся абсцесс трудно распознать. Иногда диагноз можно поставить только при помощи рентгенологического исследования. Абсцесс легкого можно принять за опухоль легкого, осумковапный плеврит, воспаление легких. Вскрывшийся абсцесс или гангрену можно спутать со вскрывшейся через бронх эмпиемой, бронхоэктазией, туберкулезной каверной (см. *соответствующие болезни*). Трудно отличить абсцесс легкого от гангрены вследствие сходства признаков. Обычно анги́рена протекает более остро: более высокая температура, большее количество мокроты с резким гнилостным запахом. Все явления при гангрене быстро нарастают, и болезнь чаще заканчивается смертью.

**Л е ч е н и е .** Свежий воздух, разнообразное питание, ограничение питья. В острых случаях при значительной интоксикации и во время приемов сульфаниламидных препаратов необходимо обильное питье.

В постели больному периодически придают такое положение, при котором лучше отходит мокрота: например, приподнимают ножной, или, наоборот, головной конец кровати (на 20—30 см на 2—3 часа).

Из лекарств применяют сульфаниламидны\* препараты (см. *Пневмония крупозная*). При абсцессах сульфаниламидные препараты применяют более продолжительное время. Необходимо наблюдать, не вызывают ли сульфаниламиды интоксикацию (потеря аппетита, тошнота, рвота, головные боли и пр.), лейкопению, дизурические явления! уменьшение выделения мочи.

Также применяют пенициллин. Эффективное лечебное действие пенициллина наблюдается только в том случае, если организм постоянно насыщен достаточным его количеством. Пенициллин вводят внутримышечно 4—6 и даже 8 раз в сутки через равные промежутки времени (через 6, 4 или 3 часа). В сутки вводят 200 000, 400 000, 600 000 единиц и более, а всего за курс лечения—4 000 000, 6 000 000, 10 000 000 единиц и более. Для уменьшения болезненности инъекций пенициллин растворяют обычно в 0,25% растворе новокаина.

Чтобы пенициллин медленнее всасывался, на место инъекции кладут пузырь со льдом, а чтобы он дольше задерживался в организме, ежедневно производят внутривенное вливание гипертонического раствора поваренной соли. Для замедления всасывания пенициллина в последнее время стали его разводить в 1% растворе пирамидона. Тогда его можно вводить через 8 и даже 12 часов. Чтобы пенициллин медленнее выделялся из организма, в него иногда прибавляют экмолин. Во флакон па каждые 100 000 единиц пенициллина прибавляют стерильно 1 мл 1% раствора новокаина и затем 1 мл экмолина. Пенициллин-экмолин вводят 2 раза в сутки по 100 000 единиц. Хорошее действие оказывает отсасывание гноя из полости абсцесса при помощи бронхоскопа с последующим введением непосредственно в бронхи раствора пенициллина (200 000—400 000 единиц). Кроме того, применяют внутривенное вливание новарсенола (6—8 вливаний с четырех-г яти дневными промежутками): сначала по 0,15, а затем увеличивают дозу до 0,3—0,45—0,6; на курс лечения назначают 2,0—2,5. Применяют еще ежедневные внутривенные вливания 10—20 мл 33% спирта или 40% раствора уротропина по 5—10 мл.

Повторные вливания крови, особенно при нарастающем малокровии, в количестве 100—200 мл оказывают часто хорошее действие.

При мучительном кашле дают успокаивающие средства: кодеин (по 0,015 три раза в день); дионин, героин (по 0,003 три раза в день). При плохом отхождении мокроты дают отхаркивающие (ипекакуана, апоморфин, сенег, термолсис), а также средства, дезинфицирующие дыхательные пути: терпингидрат, гваякол.

Rp Dionini 0,3  
Aq deatill. 15,0  
MDS По 15 капель 3 раза в день

Rp. «Inf rad. Ipeaeuanhae ex 0,6:200,0 Liq.  
Ammonii anisati Natrii bicarbenici aa 4,0 MDS  
По 1 столовой ложке через 2 часа

Rp. Apomorphi hydrochloriei 0,05 Ac. hydrochloriei  
diluti 0,5 Aq destill. 20J,0 MDS. По 1 столовой  
ложке через 2 часа

Rp. Decocti radidis Senegae ex 6,0:200,0 DS По 1  
столовой ложке через 2 часа

Rp. Inf. herbae Thermopsidis ex 0,6:200,0 DS По 1 столовой ложке через 2 часа

Rp Codeini puri 0,015  
D t. d. N. 12 in tabulettis S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp Terpini hydrati 0,5 D. t. d. N. 12 S.  
По 1 порошку 4 раза в день

Rp. Guajacoli canbncici 0,5 D. t. d. N. 12  
S. По 1 порошку 4 раза в день

Полоскать рот дезинфицирующими растворами (риванол, марганцовокислый калий).

Rp. Sol. Rivanoli (1:1000)200,0  
DS 1 столовая ложка на стакан воды для иполоскавия

Rp Kalii hypermanganici 2,0  
DS. 1—2 кристаллика на стакан воды для полоскания

При безуспешности лечения делается операция — удаляется целая доля легкого, в которой находится абсцесс.

**АБСЦЕСС ПЕЧЕНИ** см. гл. VI *Хирургические болезни*.  
**АВИТАМИНОЗ (ШПОВИТАМИН 3)** Асм. гл. X *Заболевания глаз*.  
**АВИТАМИНОЗ (ГИПОВИТАМИНОЗ) В<sub>2</sub>** Отсутствие или недостаточное содержание в пищевых продуктах витамина В<sub>2</sub> — тиамин приводит к ряду расстройств в организме, преимущественно со стороны нервной системы. К заболеванию ведет и недостаточное усвоение организмом имеющихся в пище витаминов.

Наибольшее количество витамина В<sub>2</sub> содержится в наружной оболочке (отрубях) зерновых культур, в бобовых растениях и дрожжах.

Поэтому в белой пшеничной высококачественной муке, не содержащей наружной оболочки (отрубей), не имеется витамина В<sub>2</sub>.

Суточная потребная доза тиамин для взрослого человека в среднем равна 2—3 мг.

На юго-востоке Азии и Японии наблюдается тяжелая форма авитаминоза В<sub>2</sub>, называемая бери-бери, возникающего вследствие питания беднейшего населения почти исключительно полированным (лишенным отрубей) рисом.

**Симптомы и течение.** Вначале больные жалуются на быструю утомляемость, слабость, плохой аппетит, запоры, иногда тошноту. Затем поражаются периферические нервы (полиневрит — см. *Нервные болезни*) понижение чувствительности, боли в икроножных мышцах, судороги, а затем и параличи. Развиваются явления сердечной недостаточности: одышка, отеки, тахикардия, падение кровяного давления, ослабление сердечных тонов. Иногда в первую очередь развиваются явления сердечной недостаточности. Течение болезни зависит от степени развития болезни и от своевременно принятых мер к восполнению в организме недостающих витаминов.

**Лечение.** Полноценное питание с богатым содержанием витамина В<sub>2</sub>: дрожжи пекарские и пивные, ржаной хлеб, пшеничный хлеб грубого помола (с отрубями), гречневая крупа, бобовые растения (соя, бобы, горох и др.).

Назначают витамин В<sub>2</sub> в чистом виде (тиамин). Его выпускают в пилюлях (драже), содержащих по 1—2 мг витамина в каждой пилюле. Также назначают драже, содержащее одновременно витамин В<sub>2</sub> и витамин С—СВ<sub>2</sub>.

Тиамин назначают также в виде подкожных впрыскиваний.

Rp Sol.-Thiaraini bromali 0,6% 1,0 D. t. d. N. 10  
in amp. S. По 1 мл 1—2 раза в день подкожно

**АВИТАМИНОЗ (ГИПОВИТАМИНОЗ) В<sub>2</sub>** Причиной болезни является отсутствие или недостаточное содержание в пище вита-, мина В<sub>2</sub> — р и б о ф л а в и н а .

**Р и б о ф л а в и н** имеет большое значение в процессах восстановления клеток организма для правильного его роста и для органов зрения. Недостаток рибофлавина ведет к помутнению роговицы и образованию катаракты. Витамин В<sub>2</sub> играет большую роль в белковом и углеводном обмене. Наиболее богаты рибофлавином пекарские и пивные дрожжи, печень, почки, мясо, молочные продукты, яйца. Минимальная суточная потребность взрослого человека в рибофлавине равняется 2 мг.

**Симптомы и течение.** Общая слабость, ослабление умственной деятельности, падение аппетита, трещины и болезненность слизистой губ и углов рта, красный язык со сглаженными сосочками, чувство жжения кожи, резь в глазах, слезотечение, помутнение роговицы, катаракта, конъюнктивит. В тяжелых случаях — резкая слабость, коллапс, рвота и судороги.

**Лечение.** Пища, богатая витамином В<sub>2</sub>, в первую очередь дрожжи, печенька, или печеночный экстракт (гепалон). Рибофлавин оказывает действие только при достаточном белковом питании, особенно животными белками.

Rp. Riboflavini 0,003 Sacchari albi 0,25  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Hepaloni 2,0  
D t. d. N. 10 in amp.  
S По 2 мл ежедневно для внутримышечных инъекций

**АВИТАМИНОЗ (ГИПОВИТАМИНОЗ) С** см. *Цынга*.

**АВИТАМИНОЗ (ГИПОВИТАМИНОЗ) D** см. гл. V. *Детские бв-мзии. Рахит*.

**АВИТАМИНОЗ (ГИПОВИТАМИНОЗ) K**, Витамин K содержится в зеленых листьях капусты, шпината, салата, крапивы, в некоторых животных продуктах (например, в печени). Витамин K вырабатывается также в кишечнике бактериями. Для образования витамина K

необходимо достаточное количество жиров, нормально перевариваемых, т. е. необходима нормальная функция печени.

Витамин К принимает участие в процессе свертывания крови. Он оказывает влияние на образование в печени протромбина, необходимого для свертывания крови. При отсутствии или недостаточности витамина К понижается свертываемость крови, вследствие чего развивается или усиливается кровоточивость. Поэтому при кровотечениях, особенно связанных с понижением свертываемости крови, для усиления процессов свертываемости назначают витамин К. Применяют обычно два • препарата витамина К — мет и нон и в и к а с о л.

- Rp. Methymni 0,005 01.  
Percsorum 1,0 D. t. d. N. 6  
in amp.  
S. По 1 мл для внутримышечной инъекции один раз в день
- Rp. Vicasoli 0,02  
D. t. d. N. 6 in tabul.  
8. По 1 таблетке 3 раза в день

#### АВИТАМИНОЗ (ГИПОВИТАМИНОЗ) РР см. Пеллагра.

**АВИТАМИНОЗЫ (ГИПОВИТАМИНОЗЫ)**—это заболевания, вызываемые отсутствием тех или других витаминов или недостаточным содержанием их (гиповитаминозы) в организме. Практически чаще наблюдаются не авитаминозы, а в большей или меньшей степени гиповитаминозы. В повышенном потреблении витаминов нуждаются лица тяжелого физического труда, дети, беременные и кормящие матери, жители Крайнего Севера.

Авитаминозы развиваются также вследствие разрушения витаминов в желудочно-кишечном тракте, нарушения всасываемости и усвоения их организмом, повышения их выделения. При авитаминозах нужно заботиться о полноценном питании, так как некоторые витамины усваиваются только при достаточном потреблении белков, жиров и углеводов. Так, рибофлавин (витамин В<sub>2</sub>) усваивается только при достаточном количестве в пище белков, витаминов А и К — только "при наличии достаточного количества жиров.

Витамины широко применяют с лечебной целью не только при различных авитаминозах.

При острых и хронических инфекциях, при упадке питания, при различных кровотечениях, малокровии, желудочных, кишечных, печеночных и других заболеваниях применяют те или другие витамины.

**АГРАНУЛОЦИТОЗ (AGRANULOCYTOSIS)**— это заболевание, при котором в крови резко уменьшены или даже совершенно отсутствуют зернистые лейкоциты (гранулоциты) — нейтрофилы, а иногда и эозинофилы. Причиной являются различные инфекции, протекающие с лейкопенией (уменьшением количества лейкоцитов в крови), как, например, брюшной тиф, малярия, сифилис, туберкулез, острый сепсис, хотя последний чаще бывает следствием, а не причиной болезни. Агранулоцитоз вызывается также интоксикацией различ-

ными ядами, применяемыми в промышленности, например, бензол (в резиновой, химической, кожевенной промышленности), а также некоторыми лекарственными средствами при их продолжительном применении в больших дозах (бензол, новарсенол, пирамидон, сульфаниламидные препараты, метилтиоурацил, хинин). Перезировки рентгеновыми лучами при рентгенотерапии также могут привести к агранулоцитозу.

**Симптомы и течение.** Острое начало, озноб, высокая температура, резкая боль при глотании. Основным симптом — некротическая ангина, язвенный стоматит. Состояние больных тяжелое, резкая слабость, сильный запах изо рта. Печень и селезенка увеличены. Значительная лейкопения: количество белых кровяных телец доходит до 1 000, 500 и менее лейкоцитов в 1 мм<sup>3</sup> крови. Количество эритроцитов и тромбоцитов остается без изменения. Течение болезни острое, тяжелое, прогрессирующее. Если не приняты лечебные мероприятия, болезнь заканчивается смертельным исходом в 2—3 недели.

**Лечение и профилактика.** Переливание крови — 200—400 мл за один раз или эритроцитарной массы (100—200 мл). Внутримышечное введение пенициллина от 500 000 до 1000 000 единиц в сутки (см. *Абсцесс легкого*); подкожные впрыскивания ну-клеиновокислого натрия.

Rp. Sol. Natrii nucleinici 5% Ю.О

Sterilis&tur!

S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день

• Больные должны быть обеспечены тщательным уходом, особенно за полостью рта. Полноценное питание с достаточным количеством витамина С (пастой шиповника, смородина, томатный сок и др.) и К. Применяют также препараты печени (экстракт печени, гепалон).

Rp. Hepaloni 2,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 2 мл ежедневно для внутримышечных вливаний

С профилактической целью у лиц, принимающих продолжительное время химические лекарственные препараты, следует чаще проверять состав крови и при начинающейся лейкопении немедленно прекратить применение соответствующих лекарственных средств.

**АДДИСОНОВА БОЛЕЗНЬ. БРОНЗОВАЯ БОЛЕЗНЬ (MORBUS ADDISONII).** Причиной болезни — понижение функций надпочечников (выделяющих гормоны — адреналин и корти- н) на почве поражения их туберкулезом, сифилисом и другими инфекциями, а также злокачественными опухолями.

**Симптомы и течение.** Бронзовая, коричневая пигментация кожи на открытых частях тела (лице, шее, тыльной поверхности рук, ладонных складках), на местах нормального отложения пигмента (сосках, наружных половых органах) и на слизистой оболочке щек, губ, десен и пр. Резкая мышечная и общая слабость; артериальное давление значительно понижено, сердечная деятельность ослаблена: пульс становится частым, слабого наполнения, тоны сердца глухие.

Аппетит исчезает, развивается значительное похудание, появляются головные боли, головокружение, иногда судороги, тошнота, рвота. В крови значительно уменьшаются соли натрия и увеличиваются соли калия. Иногда больные погибают в течение нескольких месяцев при явлениях общей слабости и упадка сердечной деятельности. Чаще болезнь протекает хронически с продолжительными ремиссиями или с нерезко выраженными явлениями.

**Лечение.** Специфическим средством является кортин. Его впрыскивают под кожу один-два раза в день по 1 мл, а иногда и больше — до 10 мл.

Применяют также дезойсикортикостерон-ацетат (гормон надпочечника) по 1—5 мл (5—10—20 мг) в день внутримышечно. При туберкулезном поражении надпочечников применяют стрептомицин (см. *Туберкулез, лечение*).

Достаточный отдых, свежий воздух, разнообразная питательная пища, богатая витаминами, углеводами, которую следует обильно солить. Поваренную соль (хлористый натрий) дают внутрь и как лекарство до 10—20 г в день. Одновременно проводится общеукрепляющее лечение (мышьяк, железо, рыбий жир, глицерофосфаты) (см. *Анемия*). В тяжелых случаях — постельный режим.

Пр. Cortini 1,0  
D. t. d. N. 6 in amp.  
S. По 1 мл 1—2 раза в день под кожу

**АКРОМЕГАЛИЯ (ACROMEGALIA).** Болезнь вызывается повышенной функцией передней доли придатка головного мозга (гипофиза) чаще всего вследствие развития в ней опухоли.

**Симптомы и течение.** Значительно увеличиваются кисти стоп, нижняя челюсть, ребра, грудина, а также нос, язык, губы. Заметно понижается функция половых желез. Все указанные симптомы развиваются постепенно и очень медленно. Течение болезни хроническое, продолжается иногда 20—30 лет. Больные погибают от нарастающего истощения и общей слабости.\*

**Распознавание** — на основании приведенных выше данных. Необходима рентгенограмма турецкого седла, которая обнаруживает его изменение — углубление и расширение.

**Лечение.** Хирургическое удаление опухоли. Иногда наблюдается улучшение от рентгенотерапии.

**АКТИНОМИКОЗ ЛЕГКИХ** см. гл. VI *Хирургические болезни*.

**АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСТРОФИЯ (DYSTROPHIA ALIMENTARIA)**<sup>1</sup>. Причина болезни — полное или продолжительное частичное голодание, когда расход питательных веществ преобладает над их приходом. Алиментарная дистрофия может встречаться при истощающих заболеваниях, когда организм не усваивает поступающих в него питательных веществ (рак, дизентерия и др.). Сначала питание организма при голодании происходит за счет запасов углеводов

<sup>1</sup> Alimentura — пища. AlimeciUrius — пищевой. Dystrophia — расстройство питания.

(гликогена) и жиров, а затем за счет белков (мышечной ткани и внутренних органов) — тогда и происходят значительные изменения функций органов.

**Симптомы и течение** зависят от продолжительности и степени голодания. Наиболее существенным признаком болезни является недостаток белка в тканях и крови — белковое голодание организма. Различают три стадии расстройства питания. В первой стадии: общая слабость, повышенная утомляемость, сонливость, постепенно нарастающее похудание до полного исчезновения подкожножирового слоя, боли в ногах, повышенный аппетит и жажда, частое мочеиспускание. Больные бледны, температура понижена, пульс замедлен. Ослабление полового чувства, у женщин — прекращение менструации.

Во второй стадии все указанные симптомы выражены резко. Больные постоянно ощущают чувство голода. Питание организма происходит за счет белков самих клеток и тканей. Наблюдается атрофия скелетной мускулатуры и внутренних органов. Вследствие уменьшения белка в плазме крови появляются подкожные отеки на ногах, лице, руках, а затем и в полости живота (асцит). Развивается сердечно-сосудистая недостаточность: одышка, понижение кровяного давления, ослабление пульса. Все функции организма ослабевают, уменьшается образование пищеварительных ферментов, что вызывает поносы. Кожа становится сухой, атрофичной, волосы выпадают, больные приобретают старческий вид.

В третьей стадии развиваются глубокие, необратимые изменения с угасанием функций всех органов, в том числе и центральной нервной системы... Показателем третьей стадии дистрофии является резкое ослабление или полное исчезновение аппетита. Отеки могут исчезнуть вследствие обезвоживания и уменьшения солей в организме. В некоторых случаях может не быть отеков. Эта «сухая дистрофия» обычно протекает тяжелее отечной формы.

**Распознавание** — на основании расспроса и указанных признаков. Нужно отличать алиментарную дистрофию от вторичной, которая развивается при тяжелых, истощающих болезнях: упорных поносах (хроническая дизентерия, хронические энтероколиты), раковой кахексии (худосочии), тяжелой форме туберкулеза. В отличие от почечного заболевания, главным образом нефроза, отеки при пищевой дистрофии являются безбелковыми (в моче нет белка).

**Лечение**<sup>2</sup>. В первой стадии больные лечатся амбулаторно. Следует назначать усиленное питание с достаточным количеством жиров, углеводов, белков и витаминов; полноценные Животные белки: мясо, яйца, творог, молоко.

Во второй и особенно в третьей стадии назначается постельный режим; больных держат в тепле. Кормить нужно часто (5—6 раз в день) и небольшими порциями; пища должна даваться в протертом виде. Для лучшего пищеварения дают соляную кислоту с пепсином, панкреатин (по 0,5 три раза в день). При отеках необходимо ограничить питье до 3—4 стаканов в сутки и давать малосольную пищу. При поносах пища также должна быть питательной, но в то же время щадящей и противопоносной (см. *Энтерит*,



*Колит*). Одновременно назначают сульфаниламидные препараты (дисульфан, сульгин, фталазол) (см. *Колит острый, лечение*). Больные должны получать витамины, особенно С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>; в тяжелых случаях витамины (аскорбиновая и никотиновая кислота) лучше впрыскивать под кожу. Очень полезно вводить внутривенно 40% раствор глюкозы по 50,0 (можно вместе с аскорбиновой кислотой). При «сухой дистрофии» подкожно физиологический раствор. У слабых, тяжелых больных следить за кожей, чтобы не образовались пролежни.

Rp. Ac. hydfochlorici diluti Pepsini aa 4 0 Act. destill.  
200,0 MDS. По 1 столовой ложке во время еды

Rp. Sol. Ac. nicotini 1% 10,0 Sterilisetur! DS.  
Ежедневно по 3—5 мл внутривенно

Rp. Sol. Ac. ascorbici 5% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S.  
По 1—2 М.л. внутривенно 1 раз в день

Rp. Sol. Natrii chlorati physiologicae (0,85%) 600,0  
Sterilisetur! DS. Для подкожного вливания

АЛИМЕНТАРНО-ТОКСИЧЕСКАЯ АЛЕЙКИЯ\* (СЕПТИЧЕСКАЯ АНГИНА) — тяжелое заболевание, возникающее от потребления в пищу хлеба или других продуктов (например, каши), приготовленных из зерна, перезимовавшего в поле под снегом. В таком зерне развиваются особые плесневые грибки, которые выделяют ядовитые вещества (токсины). Эти вещества поражают кровеносные органы, преимущественно костный мозг, поэтому у больных резко падает количество лейкоцитов (лейкопения), затем эритроцитов и тромбоцитов (красных пластинок).

**Симптомы и течение.** Болезнь развивается обычно через 2—3 недели после приема в пищу 2—3 кг (а иногда и меньше) перезимовавшего зерна. Вначале больной ощущает жжение во рту и глотке: на деснах и слизистой рта заметны точечные кровоизлияния и белые налеты; появляется общая слабость, быстрая утомляемость, иногда головная боль; затем может появиться тошнота и рвота, понос или запор. Явления со стороны нервной системы: угнетенное, безразличное состояние или повышенная возбудимость, плохой сон, расширение зрачков. В дальнейшем — яркочерная петехиальная сыпь (точечные кровоизлияния) на внутренней поверхности плеч

і Алейкия означает отсутствие в крови лейкоцитов (белых кровяных телец).

и бедер, на боковых частях туловища. Развиваются резкие изменения со стороны крови: быстро нарастающая лейкопения (за счет уменьшения числа нейтрофилов) — число лейкоцитов падает до 1000—500—300 и ниже в 1 мм<sup>3</sup> (см. *Агранулоцитоз*), гемоглобина — до 40—20%, число тромбоцитов — до 40 000—20 000 и ниже (при норме в 250 000—300 000 в 1 мм<sup>3</sup>). Эти изменения в составе крови ведут к развитию некротической ангины и кровоточивости.

Наиболее характерным и тяжелым симптомом болезни является **ангина**: налеты начинаются с миндалин, затем переходят на дужки, мягкое небо, язычок и заднюю стенку глотки. Они сначала желтовато-сероватого цвета, потом становятся зеленоватогрязными, начинают омертвевать, превращаясь в зловонную массу; опухают подчелюстные железы. Больным трудно и больно глотать; выделяется большое количество слюны вместе с разложившимися массами; изо рта ощущается отвратительный гнилостный запах. Некротический процесс обычно переходит на десны. В далеко зашедших случаях сыпь постепенно увеличивается, появляются кровотечения из десен, носа, глотки, желудка и кишок. Обыкновенно с появлением ангины температура повышается до 38—40°. Наступает тяжелое состояние больного.

В гнилостном содержимом полости рта развиваются различные бактерии, вызывающие вторичные инфекционные болезни (пневмонии, флегмоны и даже общий сепсис).

**Лечение.** В начале болезни (до лихорадочного периода и появления ангины) — изъятие из пищи зерновых продуктов и назначение слабительных (касторовое масло, английская соль) для очищения кишечника от остатков пораженных продуктов. Дается полноценное питание с достаточным количеством животных белков и витаминов. Помимо мяса, овощей, зелени, шиповника, ягод, можно давать кровь животных, гематоген, дрожжи. Полоскание рта и горла дезинфицирующими растворами (марганцовокислого калия, риванола, перекиси водорода); внутрь для предупреждения кровотечения раствор хлористого кальция (10% по 1 столовой ложке 3 раза в день).

В период лихорадочного состояния, развивающейся ангины, резкого малокровия и кровотечений больные должны быть помещены в больницу.

При значительной лейкопении и малокровии, а особенно при кровотечениях лучшим средством является переливание крови от 50 до 200—400\*ш с промежутком в 2—3 дня; внутривенно несколько раз в день хлористый кальций или гипертонический раствор поваренной соли; внутрь витамин С или аскорбиновая кислота, витамины В<sub>1</sub>, РР и К (оказывающий кровоостанавливающее действие). Хорошо также внутривенно вводить глюкозу в чистом виде или с аскорбиновой кислотой. Для предупреждения вторичных инфекций — различные сульфаниламидные препараты (сульфидин, сульфазол и др.) (см. *Пневмония крупозная*). При развитии септических явлений применяют также пенициллин (см. *Абсцесс легкого*).

При болях во время глотания дается только жидкая пища, но разнообразная и питательная: молоко, сливки, сметана, сливочное

масло, яйца, сладкие протертые компоты и кисели, жидкие кашицы с, маслом и сахаром, бульон, протертое мясо; печеночный экстракт (гепалон — внутримышечно). Если больной не может самостоятельно полоскать рот, последний орошают слабым раствором соды или марганцовокислого калия. Тщательно следят за кожей и за отпавлением всех органов. При ослаблении деятельности сердца применяют различные сердечные средства (камфора, кофеин; стрихнин и др.).

**П р о ф и л а к т и к а .** Широкая санитарно-просветительная работа среди сельского населения.

Rp. Acidi ascorbnici 0,1 Sacchari albi 0,3

M. f. **pulv.** D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Sol. Acidi ascorbinici 5% 1,0 D. t. d. N. 10 in amp. S. По 1—2 мл внутримышечно или внутривенно

Rp. Methynoni (Vitamin K) 0,005 01. Pirsicorum 1,0 D. t. d. in amp. N. 6 S. По 1 мл в мышцу ежедневно 3—5 дней

Rp. Vicasoli (Vitamin K) 0,015 D. t. d. N<sup>6</sup> in tab. S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp. Sol. Glucosi 40% 20,0 Sterilisetur! DS. Для внутривенного введения

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 10,0 \*  
Sterilisetur! DS. Для внутривенных вливаний

Rp. Sol. Natrii chlorati 10% 10,0 Sterilisetur! DS. Для внутривенных вливаний

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 200,0  
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

**АМИЛОИДНЫЙ НЕФРОЗ** см. *Нефроз липоидно-амилоидный.*

**АНГИНА** см. гл. IX *Заболевания уха, носа, горла.* **АНГИНА**

**СЕПТИЧЕСКАЯ** см. *Алиментарно-токсическая алейкия.*

**АНГИОХОЛИТ** см. *Холецистит.*

**АНЕВРИЗМА АОРТЫ** см. *Аортит.*

**АНЕМИЯ. МАЛОКРОВИЕ (ANAEMIA).** Наступает главным образом в результате кровотечений или отравлений (вторичное малокровие), в том числе бактериальных. Хронический сепсис, туберкулез, сифилис, малярия, всасывание продуктов гниения из кишечника при хронических заболеваниях кишечника вызывают стойкое малокровие. Малокровие развивается также при инвазии глистов и раковой болезни, хронической уремии, некоторых болезнях печени, отравлениях неорганическими и органическими ядами (свинец, ртуть, мышьяк, окись углерода, анилиновые краски, алкоголь, пищевые яды и др.). В настоящее время доказано большое значение центральной нервной системы в регуляции кроветворных процессов, а следовательно, и в развитии анемии.

**Симптомы и течение.** При остром малокровии (вследствие сильного кровотечения) наступает быстрое побледнение кожных покровов и слизистых оболочек, резкое ослабление сердечной деятельности, падение пульса (коллапс), похолодание конечностей (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность острая*). При хроническом малокровии (хронические отравления, частые незначительные кровотечения) наблюдается бледность кожи и слизистых оболочек, быстрая утомляемость, общая слабость, головокружение и головные боли. При резком малокровии больные становятся нетрудоспособными. Анализ крови: уменьшение количества гемоглобина и эритроцитов, цветной показатель меньше единицы (гипохромная анемия). Течение болезни зависит от развития основной болезни и от функциональной способности кроветворных органов (костного мозга). При полной потере способности мозга к восстановлению крови больные погибают от нарастающего малокровия и упорных кроп<sup>б</sup>-течений (см. *Анемия апластическая*).

**Р а с п о з н а в а н и е** — на основании анализа крови и указанных выше симптомов.

**Л е ч е н и е .** Лечение основной болезни, вызвавшей малокровие, укрепление организма и улучшение гигиенических условий быта. Усиленное питание разнообразной пищей, богатой витаминами и достаточным количеством полноценных: животных белков (мясо, яйца, творог). При гиперхромном малокровии печеночная диета (см. *Анемия злокачественная*) оказывает хорошее действие. Отдых в сельских условиях, санаториях и на курортах, прогулки, занятия легким спортом, водные процедуры (души, купанье). При значительном малокровии — переливание крови. При гипоре-геиераторных анемиях — внутривенные вливания небольших количеств крови (50—100 мл), лекарственное лечение: мышьяк, железо, фосфаты, гематоген (по 2 таблетки 3 раза в день во время еды.), рыбий жир (по столовой ложке 2—3 раза в день), натуральный желудочный сок, соляная кислота с пепсином (см. *Анемия апластическая*).

Rp. Sol. Natrii arseniciei 1% 1,0 D, t. d.

N. 30 in amp.

S. Начиная с 0,2 до 1,0, ежедневно по одной инъекции под квжу

Rp. Sol. arsenicalis Fowlcri 5,0  
T-rae Ferri pomati 15,0  
MDS. По 10—15—20 капель 3 раза в день после еды Rp.  
Ferri lactici 0,5  
D. t. d. N. 12 in oblatiis  
S. По 1 облатке после еды 3 раза в день Rp. Pilularum Ferri  
carbonici (Blaudii) N. 100 (с содержанием в кане," ой пилуле  
по 0,03 железа)  
DS. По 2 пилуле 3—5 раз в день Rp.  
Haematogeni 200,0  
DS. По 1 столовой ложке во время еды 3 раза в день Rp.  
Ferri rducti 1,0  
D. t. d. N. 12 in oblatiis  
S. По 1 облатке после еды 3 раза в день  
Rp. Calcii glyctrophosphorici  
Ferri glycerophosphorici aa 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 15  
S. По 1 порошку 3 раза в день

АНЕМИЯ АГАСТРИЧЕСКАЯ. Болезнь развивается после ча-  
стичной и главным образом полной резекции желудка. Железы же-  
лудка, особенно дна желудка, вырабатывают особое противоане-  
мическое вещество, которое откладывается в печени.

Симптомы и течение. Развивается гипохромная (с по-  
ниженным цветным показателем) анемия (хлоранемия см. *Хлороз*).  
Регенераторная (восстановительная) функция костного мозга понижена.  
В некоторых случаях анемия может принимать форму пер-нициозной.  
Болезнь развивается медленно, годами. При отсутствии лечения может  
принять тяжелую форму.

Лечение. Дача железа, особенно при хлоранемии (см. *Ане-  
мия*), печени или экстрактов печени (см. *Анемия злокачественная*),  
витаминов С и группы В.

«  
Пища разнообразная, богатая белками, витаминами-В<sub>1</sub> и В<sub>2</sub>,  
(дрожжи, мясо, яйца, молочные и бобовые продукты, хлеб из цельной  
пшеницы, ржаной хлеб, гречневая крупа и т. д.). В тяжелых случаях —  
переливание крови.

АНЕМИЯ АПЛАСТИЧЕСКАЯ. При апластической анемии на-  
блюдается полное или частичное прекращение функции костного мозга  
(жировое или слизистое перерождение). Причинами могут явиться  
различные инфекции, интоксикации (бензол, нонарсенол,  
сульфаниламиды и др.), рентгеновы лучи. В развитии торможения  
костномозговой функции играет роль также нарушение нервной  
регуляции процессов кроветворения.

Симптомы и течение. Быстро развивающаяся анемия с  
присущими ей симптомами. При значительном уменьшении  
тромбоцитов — кровотечения носовые, кишечные, почечные и  
др., некроз слизистой рта, десен, миндалин с кровотечениями,  
запахом изо рта, расстройством глотания. Резкая лейкопения,  
почти до полного исчезновения нейтрофилов (агранулоцитоз).

В остром периоде изнуряющая лихорадка с большими ремиссиями. При  
остром течении при полном отсутствии регенерации крови больные  
погибают в течение одного-двух месяцев. При подостром течении  
болезнь может затягиваться, давая некоторые временные улучшения.

Лечение. Систематические переливания крови по 200—400 мл  
или эритроцитарной массы — 100—200 мл. Внутримышечные введения  
пенициллина (по 400 000—800 000 единиц в сутки). Тщательный  
общий уход, уход за ртом, полноценное питание жидкой и полужидкой  
пищей, препараты печени, витамины С и К (см. *Анемия  
злокачественная, авитаминозы*).

АНЕМИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА  
(ICTERUS HAEMOLYTICUS). Развивается в результате по вышенного  
распада красных кровяных телец (гемолиз). Из гемоглобина  
образуется билирубин. При повышенном образовании билирубина  
желчь насыщена желчными пигментами.

В кишечник поступает повышенное количество желчных пиг-  
ментов, которые, изменяясь в кишечнике, поступают в кровь и  
вызывают желтуху (см. *Желтуха*).

Желтуха образуется не от поражения печени, а вследствие  
усиленного распада эритроцитов, в котором деятельное участие  
принимает селезенка, и повышенного образования желчных пигментов.  
Причины болезни неизвестны. Замечено, что иногда этой болезнью  
страдает одновременно несколько членов одной семьи. В развитии  
болезни играет роль и нарушение высшей нервной деятельности, так  
как различные тяжелые психические переживания ухудшают течение  
болезни.

Симптомы и течение. Желтуха гемолитическая  
отличается от паренхиматозной и механической: моча темная от  
уробилина, но не содержит билирубина; кал нормально окрашен; нет  
зуда кожи. Малокровие значительно выражено. Регенерация  
крови повышена. Увеличена селезенка. Течение  
хроническое; болезнь тянется годами.

Лечение. В основном — лечение анемии. В тяжелых случаях  
при развитии значительного малокровия удаляют селезенку, после чего  
обычно наступает значительное улучшение в течении болезни.

АНЕМИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ (ANAEMIA PERNICIOSA). Счи-  
тают, что причиной болезни является недостаток противоанемиче-  
ского вещества, которое образуется от воздействия особого фермента,  
вырабатываемого железами желудка, на пищевые вещества, содер-  
жащие витамины группы В (мясо, яйца, дрожжи и др.), и откладывается  
в печени. Противоанемическое вещество необходимо для нормального  
кроветворения. В настоящее время есть предположение, что это  
вещество является витамином группы В — витамином В<sub>12</sub>.

Симптомы и течение. Общая слабость, быстра»  
утомляемость, головокружение, одышка, сердцебиение. Резкая  
бледность слизистых и кожных покровов, которые принимают жел-  
товатый цвет с восковым оттенком. Язык блестящий, гладкий,  
болезненный (геитеровский язык). Ахилия. Иногда поносы. Число  
красных кровяных телец доходит до 1 000 000, 500 000 и меньше и 1  
мм<sup>3</sup>; гемоглобина — до 30 —20% и ниже. Цветной показатель

больше единицы. Эритроциты часто неправильной формы и величины (пойкилоцитоз и анизоцитоз). В кропи появляются эритроциты, содержащие ядра (нормобласты, эритробласты, мегалобласты). В тяжелых случаях больные находятся в постели. Болезнь тропическая, протекающая с временными улучшениями и ухудшениями.

**Л е ч е н и е.** Лечение сырой печенкой по 100 г два раза в день. Назначают также печеночные экстракты внутрь или, еще лучше, внутримышечно (гепалоп и др.). Таким же лечебным действием обладает гастрокрши (пысушенный свиной желудок).

Во время каждой еды дают соляную кислоту и неписин. В тяжелых случаях — переливание кропи (100—500 мл). Пища должна быть богата витаминами, особенно С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>12</sub>. В остальном лечение то же, что и при обычном малокровии (см. *Анемия*). В последнее время применяют внутримышечно витамин В<sub>12</sub>.

Rp. Ac. hydrochlorici diluti 20,0

DS. По 10—20 капель в 1/4 стакана воды до и после еды

Rp. Pepsini 0,5 D. t. d. N. 6 S. По 1

порощку после еды

Rp. Ac. hydrochloric! diluti Pepsini aa 4,0 Aq. distill.

200,0 MDS. По 1 столовой ложке по вргмя еды

Rp. Nepaloni 2,0

D. t. d. N. 12 in amp.

S. По 1 ампуле внутримышечно 1 раз в день

Rp. Gastrocrini 30,0

DS. В течение дня съесть вместе с пищей

**АНУРИЯ** — • полное прекращение отделения мочи почками, г также прекращение поступления мочи в мочевой пузь\*рь вследствие сдавления или закупорки мочеточников. Анурия ■— это симптом болезни, который наступает при острых и хронических нефритах, при лефроангпосклерозе, некоторых отравлениях (см. *Некронефроа*), при закупорке (тромбозе) почечных сосудов. Резкое обезвоживание организма при неукротимой рвоте и поносах (холера, острый гастро-внтероколит и др.); закупорка почечных канальцев и мочевых путей кристаллами сульфаниламидных препаратов вызывает анурию. Мочеточники могут закупориваться камнями или быть сдавлены опухлями. Анурия может возникать и рефлекторным путем. Закупорка одного мочеточника может рефлекторно вызвать прекращение мочеотделения другой почки. Анурия приводит к развитию уремии.

**Распознавание.** На основании клинического а урологического обследования устанавливается поражение почек, почечных сосудов, закрытие мочеточников и т. д.

Анурию следует отличать от прекращения мочеотделения из мочевого пузыря, вследствие его паралича, спазма сфинктера моче-

,-гускательного канала или «го закупорки камнем. При анурии исегда нужно проверить состояние мочевого пузыря. При «го ггере-юлнении над лобком прощупывается большей или меньшей вели-даны «опухоль», дающая при перкуссии тувай звук. В сомнительных ячаях прибегают к катетеризации.

**Л е ч е н и е** основной болезни. | При рефлекторных спазмах— тепло, теплые и горячие ванны,впрыскивания атропина, пантопона. При закупорке сульфаниламидами— промывание мочеточников содовым раствором. Для предупреждения образования сульфаниламидных отложений обильное питье при ле-чепии сульфаниламидами. Каждый прием лекарства нужно запивать V,—1 стаканом щелочной воды (минеральной, содовой).

**АОРТИТ. ВОСПАЛЕНИЕ АОРТЫ (AORTITIS). МЕЗАОРТИТ (MESAORTITIS). СИФИЛИС АОРТЫ (AORTITIS SYPHILITICA). АНЕВРИЗМА АОРТЫ (ANEURYSMA AORTAE). МЕШЕТЧАТОЕ РАСШЫРЕНИЕ АОРТЫ.** Этиология и патогенез. Воспаление аорты вызывается почти всегда сифилитической инфек--ПВВЯ, Поражается преимущественно средняя оболочка аорты (мез-пртнт). В стенке аорты образуются язвы,, вследствие чего разрушаются мышечные и эластические волокна, которые замещаются соединительной тканью; соединительная ткань, уплотняясь, образует рубцы. Стенка аорты утрачивает свою эластичность я. прочность. Поврежденная часть аорты под влиянием кров: його давления выпячивается, образуя аневризму.

•Симптомы и течение. Иногда аортиты протекают беа симптомов. Первым признаком является за грудиной боль, которая иногда носит приступообразный характер, сходный с грудой жабой.

При перкуссии — расширение аорты; при аускультат-1 ии — обычно систолический шум на аорте. Если к аортиту приео-шняясь аневризма, то признаки болезни зависят от ее величины ' асположения.. От постоянного давления аневризмы атрофируются i ужающие ее органы, даже кости. Аневризма выпячивает групу, истончает и разрушает ребра.

В втих случаях можно видеть i ощупать рукой пульсирующую аневризму под самой кожей, .-при сдавливании бронхов возникает кашель п нарушается дыхание; при сдавливании пищевода — затруднение глотания. При атеросклерозе аорты наблюдаются склеротические изменения и в других крупных артериях с соответствующими признаками (см. ■ *Атеросклероз*).

**Л е ч е н и е.** ^Следует проводить противосифилитическое лечение: начинают с внутримышечных впрыскиваний ртутных препаратов или биохннола. '

Bp. Sol. Hydrargyri cyanati 1% 20,0 Sterilisetur! DS. По 1 мл под кожу или внутримышечно ежедпгвно

Rp. Bijochinoli 40,;0

DS. По 2 мл внутримышечно через д^нь

При ртутном или висмутовом лечении для предупреждения «томати га — полоскание рта раствором бертолетовой соли или другими

дезинфицирующими растворами, а также смазывание десеп вяжущими настояками.

Кур лечения биохилом чередуют иногда с внутривенными вливаниями новарсенола (от 0,15 до 0,45 приблизительно один раз в 5 дней), всего 6—8 вливаний. Когда в аорте произошли значительные необратимые изменения, то активное противосифилитическое лечение бесполезно; назначают внутрь ртутные и йодистые препараты.

Ftp. Hydrargyri bijodati 0,1 Kalii jodati 8,0 Aq. destill. 200,0  
MDS. По 1 столовой ложке 1—3 раза в день после еды

Rp. Sol. Kalii jodati ex 8,0—200,0  
DS. По 1 столовой ложке 1—3 раза в день после еды

#### АППЕНДИЦИТ. ВОСПАЛЕНИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА

см. гл. VI Хирургические болезни.

**АРИТМИИ** — нарушение правильного ритма сердечных сокращений, следствием чего является и аритмичный пульс, когда пульсовые удары следуют неравномерно один за другим. Аритмии всегда; возникают при различных сердечных заболеваниях, функциональных нарушениях сердечно-сосудистой деятельности. Импульсы сердечных сокращений возникают в синусовом узле, находящемся в стенке правого предсердия около впадения в него полых вен. Возбуждение распространяется по предсердиям, а затем по пучку Гиса переходит на желудочки и вызывает их сокращение. При различных патологических процессах очагом возбуждения может быть любое место в сердечной мышце.

**Б л о к а д а с е р д ц а**. Блокадой называется частичное или полное прекращение проведения сердечных импульсов; тогда в нижележащих отделах сердца автоматически возникают самостоятельные очаги возбуждения. При полном нарушении проводимости по пучку Гиса желудочки начинают автоматически сокращаться, независимо от сокращений предсердий. Причиной блокады являются различные инфекции (ревматизм, дифтерия, сифилис), которые вызывают изменения в сердечной мышце. Перерождение сердечной мышцы с развитием фиброзной ткани (кардиосклероз) вызывает нарушение и прекращение проводимости. Блокада сердца выражается в урежении сокращения желудочков, а следовательно, и в урежении пульса. Предсердия сокращаются нормально, а число сокращений желудочков (ударов пульса) падает до 40—30—20 и даже меньше в одну минуту. При физической работе, волнениях учащается только сокращение предсердий, а сокращения желудочков остаются редкими.

У больных отмечаются головокружения, обмороки, бледность покровов. Им запрещается физическая работа.

**М е р ц а т е л ь н а я а р и т м и я**. Наблюдаются чрезвычайно частые сокращения (до нескольких сот в минуту) не всего предсердия в целом, а отдельных мышечных пучков, вследствие возникновения множественных очагов возбуждения в различных местах предсердий. Это объясняется нарушением питания мышцы вслед-

стане растяжения предсердий (при митральных пороках, особенно митральном стенозе) или склеротических изменений.

Многие фибриллярные сокращения (мерцания) затухают на месте; другие импульсы беспорядочно передаются в желудочки по пучку Гиса. Желудочки не могут воспринимать все импульсы, вследствие этого они сокращаются беспорядочно и неправильно; такие же явления наблюдаются и в пульсовых волнах. Последние бывают различны по величине и силе, а некоторые и не доходят до периферии, когда желудочки недостаточно заполняются кровью. Число сердечных сокращений тогда будет больше, чем ударов пульса (дефицит пульса).

**Э к с т р а с и с т о л и я**. В патологических случаях преждевременные добавочные импульсы могут образовываться в равных местах сердечной мышцы. Добавочный импульс дает и добавочное сердечное сокращение, т. е. за нормальной систолой быстро следует добавочная систола, которая, называется *э к с т р а с и с т о л о й*. Вслед за экстрасистолой наступает компенсаторная пауза, более продолжительная, чем обычная пауза, так как после экстрасистолы очередное сокращение сердца выпадает. Иногда экстрасистолы с последующей компенсаторной паузой наблюдаются после одного, двух, трех и более нормальных сокращений сердца. Если экстрасистола наступает вскоре после нормальной систолы, то может и не быть компенсаторной паузы. Тогда наблюдается добавочное сердечное сокращение и добавочный пульсовый удар. Экстрасистолу в обыденной жизни называют перебоями.

**АРТЕРИОСКЛЕРОЗ** см. *Атеросклероз*.

**АРТРИТ БРУЦЕЛЛЕЗНЫЙ** см. *Полиартриты инфекционные*.

**АРТРИТ ГОНОРРОЙНЫЙ** см. *Полиартриты инфекционные*.

**АРТРИТ ДИЗЕНТЕРИЙНЫЙ** см. *Полиартриты инфекционные*.

**АРТРИТ МОЧЕКИСЛЫЙ** см. *Подагра*.

**АРТРИТ СИФИЛИТИЧЕСКИЙ** см. *Полиартриты инфекционные*.

**АРТРИТ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ** см. *Полиартриты инфекционные*.

**АРТРИТЫ ОБЕЗОБРАЖИВАЮЩИЕ** см. *Полиартрит, обезображивающий, деформирующий*.

**АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ (ASTHMA BRONCHIALE)**. Характеризуется появлением внезапных приступов одышки, происходящих вследствие спазма (сужения) мелких бронхов. Сужение бронхов возникает от сокращения круговых мышц под влиянием возбуждения блуждающего нерва, который снабжает нервами эти круговые мышцы. Во время приступа происходит набухание слизистой оболочки бронхов и выделение секрета, состоящего преимущественно из слизи. В развитии бронхиальной астмы большую роль играет состояние центральной нервной системы. Астмой часто страдают люди с неустойчивой нервной системой.

Известно, что бронхиальная астма иногда развивается под влиянием острого психического переживания (психической травмы). Наблюдались случаи заболевания у лиц, перенесших тяжелые нервные потрясения. Приступы могут возникать вследствие условного рефлекса, действующего через кору головного мозга. У некоторых

страдающих астмой наблюдается повышенная чувствительность к какому-либо определенному веществу, называемому аллергеном (запах сена, определенных цветов, шерсти, перьев, лошадиного волоса и пота,, некоторые пищевые продукты: рыба, раки, яйца, земляника и пр.).

Бронхиальная астма относится к аллергическим заболеваниям, при которых наблюдается повышенная чувствительность организма к определенным веществам — аллергенам; последние, поступая в организм, сенсибилизируют его к данным веществам.

Не всегда больной астмой реагирует только на определенные аллергены. Иногда вообще пыль или различные запахи вызывают астматический приступ.

Реактивность всего организма, в том числе и аллергические реакции, регулируется центральной нервной системой. Следовательно, ведущая роль в развитии бронхиальной астмы как аллергического заболевания принадлежит центральной нервной системе. Иногда, развитие астмы способствуют носоглоточные полипы, искривление носовой перегородки. Повидимому, раздражения носоглотки могут рефлекторно вызывать приступы астмы. Охлаждение организма, сырое помещение и сырой климат тоже способствуют возникновению, рефлекторного астматического приступа.

Иногда в роду страдающих астмой наблюдаются различные аллергические заболевания. Возможно, что различные изменения в организме, происшедшие в ряде поколений у сенсибилизированных лиц, могут передаваться и по наследству. В таком случае эти лица являются более предрасположенными к аллергическим заболеваниям,, т. е. они становятся более реактивными к тем или иным раздражениям, исходящим из окружающей среды.

Бронхиальная астма иногда может возникать у людей различных профессий: у фармацевтов от запаха ипекакуаны, у меховщиков от урсоловых красок (урсоловая астма) и т. д.

**Симптомы и течение.** Иногда перед приступом бронхиальной астмы больной ощущает стеснение в груди и затрудненное дыхание, но обычно приступ возникает внезапно, чаще ночью: резкая одышка, страдальческое выражение лица, которое становится одутловатым,, синюшным; больной сидит, опираясь руками, чтобы фиксировать плечевой -пояс, благодаря чему вспомогательные дыхательные мышцы также принимают участие в дыхании. Часто на расстоянии слышно громкое дыхание, сопровождающееся свистом И хрипением. Вдох короткий, выдох замедлен и затруднен (экспираторная одышка). Грудная клетка, расширяется вследствие растяжения легочных альвеол воздухом. Образуется острая эмфизема легких, дающая при перкуссии коробочный звук.. Выслушивается большое количество сухих свистящих и жужжащих хрипов. Под. конец приступа часто с кашлем выделяется вязкая,, слизистая мокрота, содержащая иногда спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена и эозинофилы. Увеличение в крови аэинофилов до 8—12%, а иногда и больше. Иногда сильный кашель сопровождается рвотой. Приступы бывают не- продолжительными (несколько минут); в отдельных случаях припа-

док продолжается часами, а иногда и несколько дней. Приступы могут быть ежедневными, даже несколько раз в день, но могут не повторяться годами. Продолжительные и частые приступы ведут к развитию - хронического бронхита, эмфиземы и .сердечной недостаточности (см. *Легочное сердце*).

**Р а с п о з н а в а н и е.** Тщательно собрать анамнез. Учесть изложенные симптомы. Исключить острые и хронические бронхиты, наличие эмфиземы с бронхитом, астму сердечную (см.), уремическую (см.) и истерическую (наблюдается учащенное дыхание с усиленным вдохом и без легочных явлений).

**Л е ч е н и е.** \*\*Во время приступа придать больному наиболее удобное положение, открыть окна. Горячие водяные или горчичные ванны к ногам и рукам. Банки или горчичники па грудную клетку. Лучшим средством, обрывающим припадок, является адреналин или его препарат — эфедрин.

ftp. Sol. AdrenaHni iry.dr.achlo.rici 0,1% 1,0 Б, t, d..N. 10 In ятр, S. По 0,5—1 мл для подкожного впрыскивания

ftp. Sol. EphedrLni hvdrochlorici o% 1,0 Б. t. d. N. 10 in amp. S. Ho 0,5—1 мл для .подкожного •прыскивания

Rp. Epfeedrini Jiydrochlorioi 0,025  
Saccbari alb i 0,3 ■M, i. pnlv. ©.. i.  
d. N.. 6 S. До 1 порошку .3 рази в  
дена.

Для угнетения блуждающего нерва применяют атропин и ого препараты (белладонна, страмони).

Rp, Sol. Atropini sulfurici 0,1% 1,0 D. t. d.  
N. 10 in amp, S. П© 0,5—i мл на  
инъекцию

Иногда пользуются порошком аэтиат.ола, из которого дояют капирасы, употребляемые больными во время приступа астмы.

Rp. Fori. Belladonnae pulv.  
F-ol. Stramanii pulv. aa 15,0 Kalii  
nitrici 6,0

{ 1. i. pnlv. ►S. Сжигать по чай i Гой ложке и вдыхать

Часто применяют хлористый кальций как средство, понижающее нерлно-мышечную возбудимость.

Rp. Sol. Caiie'm chlorali 10% 10,0 Sterilistfur! DS. По  
5—10 мл для внутривенного вливания

Для понижения возбудимости нервной системы дают препараты брома.

Rp. Sol. NaM'i bromaliex 8,0:200,0 ■  
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Inf. rad. Valerianae ex 6,0:200,0: Kalii bromati 8,0 Codeini phosphoric! 0,2 MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

В последние годы с успехом применяют так называемую тканевую терапию. Под кожу больному вводят (подсаживают) кусочки какой-либо чужеродной (гетерогенной) ткани. При бронхиальной астме обычно подсаживают кусочки надпочечника, которые в норме выделяют адреналин. Тканевая терапия избавляет многих больных от приступов бронхиальной астмы.

Лечение вне приступов: общее укрепление организма, физкультура, водные обтирания или обливания, солнечные ванны или облучения кварцем. Иногда большое значение имеет перемена климата, хотя бы временная (горный или теплый сухой).

**Профилактика.** Общее укрепление организма, в том числе и нервной системы. Выявление аллергена и устранение его (перемена профессии, изъятие домашних животных и пр.), лечение

носоглотки.

**АСТМА СЕРДЕЧНАЯ (ASTHMA CARDIALE).** Сердечная астма, выражающаяся в приступах удушья, не болезнь, а синдром (совокупность симптомов, наступающих обычно ночью у сердечных больных вследствие резкого ослабления мышцы левого желудочка). Наблюдается при гипертонии, кардиосклерозе, грудной жабе, миокардитах, сифилитическом мезоартите, аортальных пороках, инфаркте миокарда. К приступам предрасполагают: чрезмерные физические напряжения, психические переживания, переедание, злоупотребление спиртными напитками, запоры со вздутием кишечника.

**Симптомы и течение.** Вследствие сильной одышки больной принужден сидеть. Сердце расширено влево (ослабление левого желудочка). Тоны сердца глухие, артериальное давление на дает. При недостаточности левого желудочка появляются застойные явления в легких и развивается их отек (см.). «

**Распознавание.** Сердечную астму надо отличать от астмы бронхиальной (молодой возраст, здоровое сердце, прекращение приступа средствами против бронхиальной астмы), уремической (см.) и истерической (в анамнезе здоровое сердце и легкие).

**Лечение.** Полный покой, приподнятое удобное положение больного, чистый, свежий воздух. Очистить кишечник; ограничить питье; частые приемы пищи небольшими порциями. При похолодании конечностей — грелки. Возбуждающие и сердечные средства: камфора, коразол, кофеин, стрихнин, адреналин, наперстянка, глюкоза со строфантом.

В случае острой сердечной недостаточности наперстянку дают и больших дозах на короткое время (2—3 дня). Rp. Inf. fol. Digitalis ex 1,5:200,0

DS. По 1 столовой ложке через 3 часа

Rp. 01. Campb.or.ati 20% 2,0 D. t. d. N. 12 in amp.

S. Для подкожного впрыскивания по 2 мл 3—6 раз в сутки

Rp. Sol. Coffcini natrio-bfnzoici 20% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. Ho 1 мл под кожу 3 раза в день

Rp. Sol. Corazoli 10% 1,° D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу 3 раза в день

Rp. Sol. Strychnini nitrici 0,1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в сутки

Rp. Sol. Glucosi 40% 20,0 T-rae Strophanthi gtt. II Sterilise tur! MDS. Для внутривенного вливания

Rp. Sol. Strophanth.ni 0,1% 0,5 Sol. Glucosi 40% 20,0 Sterilisturl S. Для внутривенного вливания

При отеке легких — кровопускание (200- .30 мл), кислород, банки, горчичники.

**АТЕРОСКЛЕРОЗ. АРТЕРИОСКЛЕРОЗ (ATHEROSCLEROSIS. ARTERIOSCLEROSIS).** Атеросклероз — заболевание артерий, сопровождающееся отложением в их стенках (преимущественно крупных) липоидов (холестерина) с последующим развитием склеротических изменений. На внутренней оболочке, а иногда и в средней отлагается холестерин в виде так называемых атероматозных бляшек, которые, распадаясь, образуют язвы. Вместо разрушенной ткани разрастается соединительная ткань, в которой отлагаются соли извести (кальция). Уплотняясь, соединительная ткань образует рубцы.

**Причины.** Нарушение жирового обмена, ожирение, холестеринемия (повышенное содержание холестерина в крови), является одной из причин развития атеросклероза. Последний наблюдается, например, при болезнях обмена: подагре, желчнокаменной болезни, ожирении, диабете.

**Избыточное питание, переедание,** особенно животной пищей (животные жиры и яйца, богатые холестерином).

Большое значение в развитии атеросклероза имеет гипертоническая болезнь. Повышенное артериальное давление в сосудах создает более благоприятные условия для отложения холестерина из крови во внутреннюю оболочку артерий.

В развитии атеросклероза главенствующее значение имеет нарушение деятельности центральной нервной системы, регулирующей обмен веществ, в том числе и холестериновый. Повышение артериального тонуса, сосудистые спазмы, возникающие от нарушений функции коры головного мозга и вегетативной нервной системы (см. *Гипертоническая болезнь*), имеют большое значение в развитии атеросклероза.

Поэтому все причины, вызывающие гипертоническую болезнь, способствуют образованию склеротических изменений в артериях.

Различные эндокринные и почечные болезни, при которых наблюдается гипертония, также способствуют развитию атеросклероза.

Предрасполагающими причинами служат отравления организма различными ядами. Сюда относятся отравления никотином, свинцом и т. д. Не только химические, но и: бактериальные яды вызывают преждевременный склероз (сифилис, туберкулез).

При артериосклерозе разрастается в стенках сосудов соединительная ткань вместо постепенно атрофирующейся мышечной и эластической с последующим отложением в стенках солей извести. Стенки артерий уплотняются, становятся толще, принимают вид извитых; эластичность их уменьшается, просвет сосуда суживается. Такие изменения отмечаются у стариков. Поэтому такая форма артериосклероза называется в о з р а с т н о й .

**Симптомы и течение.** При ощупывании—артерии плотные, извитые, трудно сжимаемы. Артериальное давление часто бывает повышено; тогда сердечная мышца гипертрофируется. С течением времени она перерождается и возникает кардиосклероз (см.). Склероз венечных артерий дает, явления грудной жабы (см.). Склероз мелких почечных артерий вызывает нефросклероз (см.). При склерозе мозговых сосудов появляются головные боли, головокружение, сонливость, ослабление памяти. При склерозе сосудов ног отмечается слабость в ногах, перемежающаяся хромота. При повышении кровяного давления от физической работы, нервных возбуждений и т. д. склерозированная артерия может разорваться, вызывая более или менее обильные кровотечения (носовые, почечные и др.). Разрыв мозговых артерий называется мозговым ударом (апоплексией или инсультом) (см. *Нервные болезни*).

**Лечение.** Ограничить физический и умственный труд, питаться преимущественно молочной растительной пищей, избегать переедания (помногу есть и пить за один прием), ограничить потребление богатых холестерином животных жиров, яиц; устранить, запоры и вздутие живота; прекратить употребление спиртных напитков и курение табака.

Если склероз сопровождается гипертонией, то общий режим и лечение те же, что при гипертонической болезни.

Из лекарств применяется главным образом иод и его препараты; щелочные минеральные воды, (боржоми, эссендуки и др.), а также растворы неорганических щелочных солей (гиперсоли).

Rp. Natrii-jodati 0,5

Aq. destill. 200,0

MDS. По 1 столовой ложке 1—3 раза в день в молоке после еды

Rp. T-rae Jod'i 20,0

DS. От 5 до 20 капель 3 раза в день после, еды в

молоке

Rp. Sajodini 0,5

D, t. d. N.. 20 in tabul.

S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды

Rp. Hypersoli 2,0

D. t. d. N. 20 in amp.

S. По 2 мл внутримышечно или внутривенно ежедневно или через день

Rp. Jod-Hypersoli 25,0

DS. По 1 чайной ложке в 1/4 стакана воды за 15 минут до еды 2 раза в день

**АТОНИЯ ЖЕЛУДКА** см. *Расширение желудка.*

**АТОНИЯ КИШЕЧНИКА** см. *Запоры.*

**АТРОФИЯ (ДИСТРОФИЯ) ПЕЧЕНИ ЖЕЛТАЯ, ОСТРАЯ** см. *Gepatit parenхиматозный острый.*

**АХИЛИЯ ЖЕЛУДКА (ACHYLIA GASTRICA).** Ахилией желудка называется отсутствие соляной кислоты и пищеварительных ферментов в желудочном соке.

Ахилия может быть временная, функциональная, вызванная психическими переживаниями или возникающая рефлекторно, а также органическая, постоянная, возникшая вследствие атрофии слизистой оболочки желудка.

Ахилия возникает как следствие гастрита (см.), так и от недостаточного белкового и витаминного питания, особенно комплекса В (см.).

При различных авитаминозах В (пеллагре) и С (цинге), а также других тяжелых заболеваниях (злокачественное малокровие, цирроз печени и др.) развивается ахилия. Различные нервные и эндокринные (гипертиреоз) нарушения могут вести к ахилии.

**Симптомы и течение.** Желудочное пищеварение может полностью компенсироваться панкреатическим (соком поджелудочной железы) пищеварением. Тогда ахилия может протекать бессимптомно. Ахилия, вызванная гастритом, сопровождается соответствующими симптомами (см. *Гастрит хронический*).

При ахилии наблюдается быстрое опорожнение желудка. Не переваренная пища раздражает кишечник, что приводит к поносам (гастрические поносы). Вследствие отсутствия дезинфицирующего действия желудочного сока пища, богатая бактериями, попадает в двенадцатиперстную кишку и инфицирует желчные пути и кишечник. Ахилия тянется годами и приводит к развитию хронического гастрита (атрофического), энтероколита, холецистита и холангита, а также, возможно, злокачественного малокровия и даже рака желудка.

**Лечение основного заболевания.** При функциональных и компенсированных ахилиях механически щадящее питание. Частое питание (4—6 раз в день). Пища размолотая мягкая, разнообразная, богатая витаминами и исключением грубой растительной клетчатки и молока (часто вызывает поносы и метеоризм).

Общеукрепляющее лечение: прогулки, занятия физкультурой, водные процедуры и пр.

При расстройстве пищеварения (поносы и пр.) соляная кислота с пепсином, натуральный желудочный сок (столовую ложку на прием во время еды), панкреатин.



Rp. Acidi hydrochlorici diluti Ptpsini aa 4,0 Aq. d/ still.  
200,0 MDS. По 1 столовой ложке во время еды

Rp. Pancreatine 0,5

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку после еды

**БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ (MORBUS BASEDOWI).**  
**ГИПЕРТИРЕОЗЫ (HYPERTHYREOSIS).** Болезнь развивается в результате повышенной функции щитовидной железы (гипертиреоз) и усиленного образования гормонов (тироксина).

Болезнь чаще наблюдается у женщин с легко возбудимой, неустойчивой нервной системой. Появление базедовой болезни отмечается после испуга, после сильных нервных потрясений.

Психическая травма и повышенная нервная возбудимость изменяют функцию щитовидной железы, повышают образование гормонов.

Изменения со стороны половых и других желез внутренней секреции действуют на щитовидную железу. Иногда базедова болезнь развивается после удаления фибромы матки, после аборта и пр.

Различные инфекции (грипп, тифы, туберкулез, тонзиллиты и др.) иногда дают толчок к возникновению базедовой болезни.

**Симптомы и течение.** Три основных симптома: воб (увеличенная щитовидная железа), пучеглазие и тахикардия (учащение пульса). Заметно дрожание рук, а иногда и всего тела. Больные худеют, становятся раздражительными, страдают бессонницей, повышенной потливостью, испытывают чувство жара; суб-фебрильная температура (37—37,5°). Болезнь может начаться остро, с быстрым развитием всех признаков, резким упадком питания, усилением сердечной декомпенсации. Такие больные могут погибнуть от общего истощения и сердечной недостаточности. Чаще болезнь протекает хронически, с периодическими улучшениями и последующими обострениями.

В некоторых резко выраженных случаях имеется только часть указанных симптомов, например, у больного наблюдаются тахикардия, субфебрильная температура, повышенная возбудимость нервной системы, но пучеглазие и зоба нет. Такие случаи называют гипертиреозом (повышенной функцией щитовидной железы).

**Лечение.** Необходимо создать спокойную обстановку. В острых случаях больных помещают в больницу или санаторий. Пища питательная и разнообразная, молочно-растительная, богатая витаминами. Избегать мяса и мясных супов. Запрещаются алкогольные напитки, курение, кофе и крепкий чай. Внутрь — средства, успокаивающие нервную систему: валериановые капли (по 10 капель 3 раза в день), бромистые препараты, бромурал (по 0,3 три раза в день), люминал (по 0,05 2 раза в день), а также малые дозы иода.

Rp. Inf. rad. Valerianae 8,0:200,0 Natrii bromati 8.0  
MDS. По столовой ложке 3 раза в день

Rp. Jodi puri 0,2

Kalii jodati 0,4 Aq. destill. 20,0 MDS. От 5 до 10 капель  
3 раза в день после еды

Специфически действуют тироурацил и менее токсичный метилтироурацил; их дают по 0,2 десять дней три раза в день, 10 дней два раза в день, 10 и больше дней один раз в день. Эти препараты пужно применять очень осторожно — возможно отравление (тошнота, рвота, лейкопения, повышение температуры).

При нерезко выраженных (стертых) случаях: малые дозы иода, люминала и метилтиоурацила.

Rp. Jodi puri 0,02 Kalii jodati 0,2 Luminali 0,4 ■ Methyl-  
thiouracili 2,0 Extr. et pulvis liquiritiae q. s. ut f. pil. N.  
40 MDS. По 1 пилюле 2 раза в день после еды

В тяжелых случаях, не поддающихся обычным способам лечения, приходится прибегать к операции (частичное удаление щитовидной железы).

**БЕЛОКРОВИЕ** см. *Лейкемия*.

**БЕРИ-БЕРИ** см. *Авитаминоз В1*.

**БЛЕДНАЯ НЕМОЧЬ** см. *Хлороз*.

**БЛОКАДА СЕРДЦА** см. *Аритмии*.

**БЛУЖДАЮЩАЯ ИЛИ ПОДВИЖНАЯ ПОЧКА** см. *Почка опущенная*.

**БОТКИНА БОЛЕЗНЬ.** С. П. Боткин первый указал, что некоторые острые гепатиты вызываются инфекцией; с тех пор эти болезни стали называть инфекционными желтухами.

Раньше инфекционные желтухи неправильно назывались катаральными или простыми желтухами. В настоящее время различают две формы первичных инфекционных желтух: болезнь Боткина и болезнь Васильева-Всйля (см. гл. II *Инфекционные болезни*). Инфекционная желтуха иногда распространяется в виде небольших эпидемий — заболевают лица одной семьи или одного общежития.

В настоящее время, главным образом советскими учеными, установлено, что возбудителем болезни Боткина является фильтрующийся вирус, который находится в крови больного и выделяется с испражнениями и мочой. Инкубационный период от 20 до 45 дней и более. Заражение происходит через загрязненные руки, мух. Могут быть заболевания при переливании крови и при проведении профилактических прививок, в том числе серопротектики кори (сыворотка от больных болезнью Боткина), при инъекциях недостаточно простерилизованным шприцем или иглами.

**Симптомы и течение болезни.** Основным симптомом острых инфекционных гепатитов является желтуха. Часто желтухе предшествуют нарушения желудочно-кишечной

деятельности: плохой аппетит, отрыжка, запоры или поносы, иногда рвота. Затем повышается температура, и через несколько дней появляется желтушное окрашивание склер и кожи. Раньше всего отличается желтушное окрашивание белочной оболочки глаз, затем кожи. В связи с желтухой (паренхиматозной) наблюдаются все те изменения со стороны кала, мочи, пульса и пр., о которых говорится в разделе «Желтуха» (см.).

Больные часто ощущают боль в печени. Печень иногда довольно значительно припухает. В некоторых случаях прощупывается увеличенная селезенка. Болезнь Боткина может протекать очень легко, с незначительными клиническими признаками, и очень бурно, сопровождаясь значительными разрушениями печеночной паренхимы. РОЭ умеренно увеличивается (25—30 мм в час).

В легких случаях повышенная температура держится около недели, затем постепенно начинает спадать. Воспалительные явления в печени проходят, желчь снова поступает в кишечник и окрашивает испражнения. Кожа постепенно принимает нормальный вид, самочувствие улучшается, силы больного восстанавливаются. Болезнь продолжается 3—4 недели.

Иногда болезнь Боткина протекает более тяжело: дольше длится лихорадочный период, желтуха держится 2—3 месяца и выздоровление наступает постепенно. Иногда в период улучшения наступает вновь обострение болезни с усилением желтухи и других признаков болезни.

Тяжелые формы болезни Боткина, так же как и другие острые паренхиматозные гепатиты, могут закончиться значительными дистрофическими изменениями печени с некрозом печеночной ткани. Такая форма острого гепатита называется острой дистрофией печени и обычно оканчивается смертью.

Тяжелое течение болезни Боткина с явлениями острой печеночной дистрофии наблюдается иногда у беременных, особенно после 3—4 месяцев беременности. Острая дистрофия печени протекает с высокой температурой, быстро развивается значительная слабость, печень значительно уменьшается в размерах (атрофия), больные часто впадают в бессознательное состояние и в течение нескольких дней погибают.

**Распознавание.** Дифференцировать приходится с другими острыми паренхиматозными гепатитами: с инфекционной желтухой Васильева-Вейля, со вторичными и токсическими острыми гепатитами (см. *Гепатит паренхиматозный острый*). От лептоспироза (болезнь Васильева-Вейля) это заболевание отличается более длительным инкубационным периодом, более медленным началом, более умеренной температурой и отсутствием альбинурии, гематурии и других видов кровотечения (кровоая рвота, кровавый стул и др.).

**Лечение.** Постельный режим. Обильное питье (но кислое!). Пища должна быть смешанная, но преимущественно углеводистая: пемясные супы, вареные овощи и фрукты, компоты, белый хлеб, нежирное молоко, молочные каши, вареный картофель, сли-

вочное масло в небольшом количестве, побольше сладкого (сахар, варенье, мед, сладкие кисели и компоты). Белки — главным образом творог, нежирные мясо и рыбу в вареном виде в небольшом количестве. Пища должна быть богата витаминами, особенно витамином С. Нельзя давать мясных (рыбных) супов, жареного мяса, закусок, острых приправ, яиц (желтков), жирных продуктов. На область печени — грелка или согревающий компресс. Следить за регулярным действием кишечника; давать слабительные соли натошак — карлсбадская соль по чайной ложке на прием.

Вр. Salis. Carolini factitii 50,0

DS. 1 чайную ложку на стакан воды, выпить в течение 15 минут натошак

Внутрь дают щелочи и щелочные воды (боржом, эссенуки и др.), затем назначают дезинфицирующие средства — салол или уротропин (по 0,5 три раза в день) (иногда с белладонной). Уротропин лучше вводить внутривенно.

Кр. Sol. Urotropini 40% 10,0 Sterilisetur!

DS. По 5—10 мл внутривенно

При тяжелых формах внутривенные вливания раствора глюкозы одновременно с подкожными впрыскиваниями инсулина (гормон поджелудочной железы).

Вр. Sol. Glucosi 40% 20,0 Sterilisetur! DS. Для внутривенного вливания

Вр. Insullni 5,0

DS. От 5 до 10 единиц под кожу 2 раза в день

(В 1 мл содержится 20 или 40 единиц инсулина, о чем имеется указание на этикетке).

Инсулин вводится для лучшего усвоения углеводов организмом и для накопления в печени гликогена (сахара), который предохраняет печеночную клетку от разрушения. Если больной мало получает витаминов, то назначают аскорбиновую кислоту внутрь или иод кожу, а также витамины В! и К.

Вр. Sol. Acidi ascorbici -5% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. • S. По 1 мл 1—2 раза в день под кожу

Вр. Sol. Thiamini 0,6% 1,0 D. t. d. N. 10 in amp. S. По 1 мл 1 раз в день подкожно

Rp. Vicasoli 0,02

Sacchari albi 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 12

S. По 1 порошок 3 раза в день

Хорошо действует внутримышечное применение печеночного экстракта. При острых дистрофиях печени большие дозы гепалона иногда приостанавливают дальнейший процесс — и постепенно наступает выздоровление.

Rp. Hepaloni 1,0

D. t. d. N. 10 in amp.

S. По 1—2 ампуле внутримышечно 1 раз в день

При ослаблении сердечной деятельности подкожно сердечные возбуждающие (кофеин, кдмфора, коразол). При кожном зуде теплые ванны с содой (400,0 на ванну) и ежедневное обтирание кожи раствором уксуса, 2% раствором карболовой кислоты.

**П р о ф и л а к т и к а .** Испражнения и мочу больных необходимо обезвреживать 3% раствором хлорамина. Подкладные судна и утки обезвреживают в 3% растворе хлорамина. Необходимо тщательно стерилизовать шприцы, иглы до и после употребления, так как больные инфекционным гепатитом являются заразными в инкубационном периоде.

**БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА** см. *Астма бронхиальная.*

**БРОНХИТ ОСТРЫЙ (BRONCHITIS ACUTA).** Основная причина-инфекция (пневмококки, пневмобациллы, реже стафилококки, стрептококки и другие бактерии). Эти микробы и у здоровых людей обитают на слизистой дыхательных путей. Когда понижается сопротивляемость организма (от простуды, охлаждения и других причин), бактерии поражают слизистую оболочку и вызывают воспаление. Бронхиты, так же как и воспаления верхних дыхательных путей, называют простудными или сезонными катаррами дыхательных путей. Их часто смешивают с гриппом, так как при гриппе тоже часто наблюдается насморк и кашель. При некоторых инфекционных болезнях бронхит является одним из признаков этих болезней (грипп, корь, туберкулез легких, иногда брюшной тиф и др.). Химические вещества, вызывая раздражение, также могут быть причиной воспаления дыхательных путей, в том числе и бронхов.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Основной признак: кашель сухой (сухой бронхит) или влажный с выделением слизисто-гноной мокроты. При сухом бронхите выслушиваются сухие свистящие и жужжащие хрипы, при влажном — крупно-, средне- или мелкопузырчатые. Перкуторный звук без изменений. При распространенном бронхите, особенно при поражении мелких бронхов, наблюдается одышка. Инфекционные бронхиты сопровождаются повышением температуры (37—38°), общей слабостью, недомоганием. Инфекционный острый бронхит в среднем длится 1—2 недели; у ослабленных, истощенных больных бронхиты могут затягиваться, особенно если они вызваны туберкулезной инфекцией.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Труднее всего решить вопрос: имеется ли только бронхит или одновременно и пневмония. При бронхопневмонии обычно температура более высокая, при перкуссии могут быть очаги притупления; кроме мелкопузырчатых, выслушиваются иногда и крепитирующие хрипы (см. *Пневмония очаговая*).

**Л е ч е н и е.** При повышенной температуре — постельное содержание. Чистый нехолодный воздух в помещении. На грудную

клетку банки или горчичники, иногда круговой согревающий компресс. Обильное горячее питье: горячее молоко с содой ( $V_2$ —1 чайная ложка на стакан) с боржомом (пополам), чай с малиной (малиновым вареньем). При лихорадочном состоянии — аспирин (но 0,5 три раза в день). При сильном, особенно сухом, кашле, а также при значительной одышке — успокаивающие средства: кодеин (по 0,015 три раза в день), дионин, лавровишневые капли.

Rp. Codeini puri 0,015

Natrii bicarbonici 0,25

D. t. d. N. 12

MDS. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Dionini 0,2

Aq. laurocerasi 20,0

S. По 20 капель 3 раза в день

Rp. Sol. Dionini 2% 15,0

DS. По 15 капель 3 раза в день

При трудно отделяемой мокроте назначаются отхаркивающие средства: ипекакуана, апоморфин, сенег, термопсис.

Если при влажном бронхите наблюдается сильный кашель, то дают отхаркивающие средства в сочетании с наркотическими.

Rp. Inf. herbae Thermopsisidis ex 1,0:200,0 DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Sol. Apomorphini hydrochlorici ex 0,05 : 200,0 Ac. hydrochlorici diluti 0,5 MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Dec. rad. Sencgae ex 6,0:200,0 DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Codeini puri 0,015

Terpini hydrati 0,25

D. t. d. N. 6 in tab.

S. lib 1 таблетке 3 раза в день

Rp. Inf. rad. Ipecacuanhae ex 0,5:200,0 Liq. Ammonii amsati Ufatrui bicarbonici aa 4,0 Codeini phosphoric 0;15 MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

При сопутствующем бронхите лечить главным образом основное заболевание.

**БРОНХИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (BRONCHITIS CHRONICA).** Болезнь развивается после повторных острых бронхитов, при длительном вдыхании ядовитых газов, пыли и многолетнем курении, при застое в малом кругу кровообращения, эмфиземе, пневмосклерозах.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е** те же, что и при остром бронхите. Неинфекционные бронхиты протекают с нормальной темпе-

ратурой. Хронические бронхиты тянутся годами. Осложнения — эмфизема легких и бронхоэктазия. Хронические бронхиты предрасполагают к инфекционным болезням (туберкулезу и др.).

**Р а с п о з н а в а н и е .** Хронический бронхит нужно отличать от хронического ларингита и трахеита, от бронхоэктазии, бронхиальной астмы и туберкулеза легких.

**Л е ч е н и е .** По мере возможности устранить вредные моменты и лечить заболевания, поддерживающие бронхит. В основном лечение симптоматическое (как при остром бронхите). Общеукрепляющее лечение в санаторных условиях показано при затяжных бронхитах, особенно связанных с заболеванием легких. При эмфиземе и застойных бронхитах, вызванные недостаточностью сердца, основное лечение заключается в укреплении сердечной мышцы.

**БРОНХОПНЕВМОНИЯ** см. *Пневмония очаговая.*

**БРОНХОЭКТАЗИЯ — РАСШИРЕНИЕ БРОНХОВ (BRONCHOECTASIA).** Расширения бронхов бывают врожденные и приобретенные. Приобретенные образуются вторично как осложнения при хронических бронхитах, после частых пневмоний, при туберкулезе легких, иногда после выпотных плевритов. При хроническом воспалении бронхов происходят изменения в слизистой и в мышечной оболочке бронхов. Эластическая ткань заменяется соединительной и стенки бронхов становятся податливыми. Соединительная ткань, разрастаясь около бронхов, уплотняется и растягивает бронхи. Склеротические изменения в легких (пневмосклероз) после пневмоний и при туберкулезе вызывают сморщивание легочной ткани, что также ведет к расширению бронхов. Бронхоэктазы бывают цилиндрические (равномерные расширения), веретенообразные и мешотчатые.

**С им п то м ы и т е ч е н и е .** По утрам больной с сильным кашлем выделяет мокроту «полным ртом», т. е. сразу большое ее количество. Такое выделение мокроты характерно для опорожнения полости. Мокрота жидкая, гнойная. В более поздней стадии болезни, когда в полостях бронхов начинают развиваться гнилостные бактерии, мокрота приобретает гнилостный, вонючий запах. Часто наблюдается кровохаркание и кровотечение вследствие разрыва кровеносных сосудов в истонченных стенках расширенных бронхов. Образование гнилостной мокроты в течение долгого времени приводит к общей интоксикации организма: появляется бледность, похудание, общая слабость, пальцы принимают вид барабанных палочек. Расширение бронхов развивается в нижних отделах легких; над ними можно обнаружить некоторое притупление звука (склеротические изменения в легких). При выслушивании отмечаются различные хрипы, главным образом крупнопузырчатые. Большие мешотчатые расширения бронхов могут давать признаки каверны: тимпанический звук, бронхиальное или амфорическое дыхание.

Бронхоэктазия — болезнь хроническая, тянется годами с постепенным ухудшением. Вначале болезнь протекает как хронический бронхит, затем появляется гнилостная мокрота и картина общей интоксикации. Часто бронхоэктазия осложняется пневмонией. С течением времени развивается легочная эмфизема и недо-

статочность сердца — одышка, цианоз. Следствием хронической общей интоксикации может развиться липойдно-амилоидный нефроз.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Надо отличать от абсцесса или гангрены легких, от туберкулезной каверны (см. *соответствующие болезни*).

**Л е ч е н и е .** Общеукрепляющее: усиленное питание, лечение малокровия (сжт.). Желательно пребывание в теплом климате. В остальном лечение симптоматическое. В постели придавать больному такое положение, которое облегчает отхождение мокроты: ножной конец кровати поднять на 20—30 см в продолжение 2—3 часов и принять такое положение, при котором происходит лучшее отхождение мокроты. Банки, отхаркивающие средства (термопсис, сенегал) и дезинфицирующие (терпигидрат, гваякол, тиокол, креозот).

Rp. Inf. nerbae Thermopsidis ex 0,6 :200,0 DS. По 1 столовой ложке через 3 часа

Rp. Thiocoli 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Terp'ni hydrati 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 4 раза в день

Rp. Crcosoti fagi 15,0

DS. По 5 капель 3 раза в день в молоке после еды

Частое полоскание рта дезинфицирующими растворами (риванола, марганцовокислого калия, перекиси водорода).

При кровохаркании или легочном кровотечении — обычные мероприятия (см. *Кровотечение легочное*).

С большим успехом применяют отсасывание гноя из бронхоэктазов при помощи бронхоскопа с последующим введением в них раствора пеницилина (200 000—400 000 единиц).

При обострениях, особенно связанных с повышением температуры, применяют пенициллин внутримышечно (см. *Абсцесс легких*).

Благотворное влияние на течение болезни оказывает длительное пребывание в условиях теплого морского климата (например, побережье Черного моря).

**П р о ф и л а к т и к а .** Предупреждать заболевание бронхитом, избегать пыли, охлаждения. Запретить курение.

**ВАСИЛЬЕВА-ВЕЙЛЯ БОЛЕЗНЬ** см. *Инфекционная желтуха* гл. II *Инфекционные болезни*.

**ВЕРЛЬГОФА БОЛЕЗНЬ** см. *Тромбопения*.

**ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ.** Болезнь возникает в разреженной атмосфере (понижение атмосферного давления) от недостатка кислорода, а также от недостаточного содержания углекислоты в крови вследствие ее усиленного выделения при учащенном и углубленном дыхании. Болезненные явления могут уже появиться на высоте 2 000 м над уровнем моря. Обычно болезнь развивается на высоте 4 000—5 000 м. При всякой физической

работе потребность в кислороде повышается. Поэтому при восхождении на горы (альпинизм) явления гипоксемии (пониженное содержание кислорода в крови) наступают быстрее, чем на той же высоте у лиц, находящихся в покое (например, на самолете).

**Симптомы и течение.** При восхождении пешком в первую очередь появляется мышечная слабость, затем одышка, углубленное и учащенное дыхание, учащение сердечной деятельности, головокружение, тошнота, рвота. Затем вследствие расширения кровеносных сосудов появляются кровотечения носовые, легочные. Высотная болезнь у лиц, находящихся в покое (в самолете), часто начинается с мозговых явлений: сонливость, головокружение, апатия, судороги и потеря сознания.

В некоторых случаях внезапно могут возникнуть явления коллапса. При резких изменениях атмосферного давления (например, быстром подъеме самолета) появляются сильные боли в придаточных полостях (лобных, гайморовых), ушах, суставах.

У разных людей бывает различная приспособляемость к разреженной атмосфере. Постоянно живущие на больших высотах более приспособлены к недостатку кислорода. Большое значение имеет постоянная тренировка к подъемам, известное привыкание к разреженному воздуху. Особенно тяжело переносят подъемы больные легочными и сердечными заболеваниями, гипертонией, страдающие малокровием, хотя в обычных условиях они и являются практически здоровыми (в состоянии компенсации).

**Профилактика и лечение.** Перед подъемом и на значительных высотах — легкая еда, без переполнения желудка. При подъемах на горы необходима предварительная тренировка. Итти следует медленно и постепенно, дышать ровно и глубоко, устраивать частые отдыхи. Одежда свободная, не стесняющая, легкая. Оберегать себя от сильных солнечных лучей и перегревания: При полетах выше 4 000—5 000 м пользоваться кислородным прибором.

При появлении вышеуказанных симптомов высотной болезни необходимо прекратить подъем и дать отдых или еще лучше спустить пострадавшего в более низкое место. Во время полета рекомендуется вдыхание кислорода, которое быстро снимает многие симптомы болезни.

При сердечной слабости — впрыскивание камфоры, кофеина; при головных болях — пирамидон или фенацетин с кофеином.

В качестве противорвотного средства профилактически применяют таблетки азрона, который содержит препараты атропина (гиосциамин и скополамин).

Rp. Aeroni 0,0005 D, t. d. in tab. S. "По 1—2 таблетки на прием за 1 час до полета"

**ГАНГРЕНА ЛЕГКОГО** см. Абсцесс легкого.

**ГАСТРИТ ОСТРЫЙ, ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛУДКА (GASTRITIS ACUTA).** Острый гастрит возникает от различных раздражений стенки желудка. Пищевые раздражения: от чрезмерного количества пищи, особенно грубой, неудобоваримой, слишком жирной — жареная свинина, гусь, жареные пироги и пр., плохо пережеванной

или слишком холодной; пищевые отравления, вызываемые недоброкачественной пищей; всевозможные яды — кислоты, щелочи, мышьяк, ртутные препараты (сулема), алкоголь, длительное применение некоторых лекарств (адониса, наперстянки, салицилового натрия, йодистых препаратов); повышенная чувствительность к некоторым пищевым веществам (яйцам, ракам, землянике и др.). Острый гастрит развивается не только от местных раздражений слизистой желудка, но и в значительной степени от нервной регуляции функции желудка.

**Симптомы и течение.** Рвота сначала пищей, а затем слизью и желчью; — при ожогах — примесь крови. Боли в области желудка, иногда схваткообразные. Аппетит отсутствует, язык обложен, отрыжка, изжога, тошнота. При гастритах, вызванных инфекцией, употреблением недоброкачественных продуктов, наблюдаются явления общего отравления: повышенная температура, общая слабость, головная боль. В тяжелых случаях — резкий упадок сердечной деятельности (коллапс): бледность покровов, похолодание конечностей, учащенный пульс слабого наполнения. После устранения причины, вызвавшей заболевание, острые явления проходят в течение нескольких дней, и постепенно восстанавливается здоровье. В некоторых случаях, особенно когда продолжаются раздражения желудка (грубой пищей, алкоголем и пр.), острый гастрит может перейти в хронический. При различных острых отравлениях больной может погибнуть от общей интоксикации организма.

**Распознавание.** Острый гастрит необходимо отличать от язвы желудка. При повышенной температуре — от острых заболеваний органов живота (аппендицита, холецистита, госпал<ния придатков). В постановке диагноза большую роль играет анамнез больного: внезапность начала заболевания, связанного с приемом пищи, ее качеством, наличие различных отравлений и пр.

**Лечение.** Промывание желудка. В случае невозможности промыть желудок, давать больному пить в большом количестве теплую воду, лучше с примесью соды, после чего искусственно вызвать рвоту (шепотание глотки и пр.). Если рвотные движения прекратились, дают слабительные (касторовое масло, английскую или глауберову соль), чтобы быстрее вывести из кишечника яды, успевшие попасть туда из желудка.

Постельное содержание. На живот грелку или согревающий компресс, грелки к рукам и ногам. При сильных болях — атропин или даже морфин под кожу.

Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 1,0 D. t. d. N 6 in amp. S. 1 мл под кожу

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici 1% 1,0 D. t. d. N. 3 in amp. S. 0,5—1,0 мл под кожу

Первые 1—2 дня болезни лучше совсем не давать пищу. Обильное питье и теплом или еще лучше в горячем виде (чай с лимоном, кофе с молоком, прокипяченная вода). Против мучительных позывов

к рвоте рекомендуется горячее питье глотками. Иногда лучше помогает глотание кусочков льда. При ожогах желудка крепкими щелочами и кислотами — глотать кусочки льда; пить глотками холодную (со льда) воду, сливки, глотать мороженое небольшими порциями. При упорной рвоте — подкожные вливания физиологического или рингеровского раствора или раствора глюкозы (см. *Пищеводное воспаление*). После того как пройдут острые явления, дают нераздражающую жидкую и полужидкую пищу: бульон, слизистые отвары, кисели, желе, хорошо проваренные молочные каши со сливочным маслом или сахаром.

Внутрь — белладонна со щелочами (содой или магниезией) или дезинфицирующими средствами (салол).

Rp. Extr. Belladonnae 0,015 Magnesiae  
ustae 0,5 M. i. pulv. D. t. d. N. 10  
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Extr. Belladonnae 0,015 Natrii  
bicarbonici 0,3 M. f. pulv. D. t. d. N.  
10 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Extr. Belladonnae 0,015  
Saloli 0,5  
M. f. pulv. D. t. d. N. W S. По 1  
порошку 3 раза в день

При ослаблении сердечной деятельности — сердечные средства (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность*).

**ГАСТРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (GASTRITIS CHRONICA).** Острый гастрит переходит в хронический, если не устранена причина болезни или продолжают раздражения слизистой желудка (грубой пищей, алкоголем и пр.). Развитию гастрита способствуют: нерегулярное питание, редкие приемы пищи, поглощение слишком обильной или грубой пищи, недостаточное разжевывание, еда наспех, всухомятку, чрезмерно горячая и холодная пища и питье, острые приправы, хроническое отравление алкоголем. Чаще хронический гастрит возникает как осложнение в сопутствующее явление при различных заболеваниях: при язве и раке желудка; далее при холецистите, туберкулезе, сифилисе, злокачественном малокровии (атрофический катарр), декомпенсации сердца (от венозного застоя в слизистой желудка), воспалении почек (выделение слизистой желудка продуктов обмена). Большое значение в возникновении возвратов болезни и ее течении имеет нарушение первичной регуляции и состояние психики больного. Недостаточность питания и витаминов комплекса В, С и др. ведет к нарушению регенеративных процессов в стенке желудка, что способствует атрофии слизистой оболочки его. От постоянного раздражения слизистая желудка гипертрофируется, поэтому такой хронический катарр желудка называется гипертрофическим. Гипертрофированная слизистая усиленно выделяет желудочный сок (кислый катарр желудка).

При атрофическом катарре слизистая оболочка постепенно атрофируется, замещается соединительной тканью, вследствие чего выработка желудочного сока уменьшается или совсем прекращается (атрофический катарр) и наступает ахилия желудка (см.).

**Симптомы и течение.** Тяжесть или боль в подложечной области, отрыжка, изжога, иногда тошнота и рвота. Все эти явления наблюдаются или усиливаются в связи с принятой пищей, особенно если больной не соблюдает диетических предписаний. При кислотном катарре бывает кислая отрыжка и рвотные массы кислого запаха. Вследствие процессов гниения, происходящих в желудке, наблюдается тухлая отрыжка. При ощупывании живота — разлитая болезненность в подложечной области. При исследовании желудочного сока — повышенная или пониженная кислотность или даже полное отсутствие соляной кислоты и ферментов. Болезнь может тянуться годами, периодически улучшаясь или ухудшаясь, в зависимости от образа жизни больного и соответствующих лечебных мероприятий.

**Распознавание.** Надо отличать от хронического течения язвы желудка и начальных явлений рака желудка (см. *соответствующие болезни*).

**Лечение.** Основное — соблюдение правильного пищевого режима и соответствующей диеты; есть часто, но небольшими порциями, хорошо разжевывать пищу, особенно при пониженной кислотности; пища должна быть питательной, содержащей достаточное количество калорий, но не раздражающей воспаленной слизистой оболочки и необременительной и не грубой. При атрофическом катарре пища должна быть механически и химически щадящей. При кислотном катарре нельзя употреблять свежий черный хлеб, сдобные пироги, жирное жареное мясо и рыбу, различные непротертые овощи — капусту, огурцы и пр., острую пищу (пряности, подливки, соуса и соленые блюда), так как она раздражает слизистую оболочку и увеличивает отделение желудочного сока. При увеличенной кислотности нельзя есть кислый черный хлеб, кислую капусту, кислое молоко, кислые фрукты, а также бульоны и жареное мясо (повышают кислотность). При атрофическом катарре, пониженной кислотности и ахилии допускаются некоторые приправы и пряности, которые, раздражая слизистую, могут увеличивать кислотность желудочного сока; пища рубленая или протертая. При гастрите с повышенной кислотностью разрешается: молоко, сливки, слизистые протертые супы (протертые крупы и овощи), сливочное масло, черствый белый хлеб, каши, картофельное пюре, яйца, паровые котлеты, вареное нежирное мясо и рыба, протертые овощи и некислые фрукты. Пища должна быть малосольной. При пониженной кислотности назначают ту же диету, на пищу можно соли по вкусу, дают еще мясные супы, кислые продукты (фрукты и кисели) и некоторые пряности (горчицу, уксус, перец).

Лекарства: при увеличенной кислотности — атропин или белладонна (болеутоляющие и понижающие кислотность), сода, магнезия, висмут (понижающие кислотность).

- Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 10,0  
DS. По 8 капель 2 раза в день перед едой
- Rp. Extr. Belladonnae 0,015 Natrii bicarbonici 0,5 M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошок 3 раза в день перед едой
- Rp. Extr. Belladonnae 0,015 Bismuti subnitrici Magnesiaе ustae aa 0,5 M. t. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1 порошок перед едой 3 раза в день

При уменьшении или полном отсутствии кислотности назначают натуральный желудочный сок, столовую ложку во время еды два-три раза в день или раствор соляной кислоты иногда с пепсином, а также горечи.

- Rp. Ac. hydrochlorici diluti 15,0  
DS. По 10—20 капель во время еды
- Rp. Ac. hydrochlorici diluti Pepsini aa 4,0 Aq. destill. 200,0 MDS. По 1 столовой ложке во время еды
- Rp. T-rae Amarae 25,0  
DS. По 25 капель перед едой
- Rp. T-rae Nucis vomicae 5,0  
T-rae Chinae compositae 20,0, MDS.  
По 8—15 капель перед едой

При наличии большого количества слизи, частых рвотах и особенно при гнилостных процессах — промывания желудка натошак: при повышенной кислотности — 2% раствором двууглекислой соды, а при пониженной — физиологическим раствором поваренной соли.

При увеличенной кислотности рекомендуются курорты Боржоми, Железноводск, при пониженной — Ессентуки. Курортное лечение имеет еще то преимущество, что больной соблюдает определенный режим, пользуясь диетическим столом и соответствующим отдыхом.

**ГASTРОПТОЗ. ОПУЩЕНИЕ ЖЕЛУДКА (GASTROPTOSIS).** Опушение желудка и других органов живота происходит при общей слабости организма, слабости брюшного пресса и связочного аппарата, поддерживающего желудок. Часто наблюдается у многожавших женщин с дряблым животом и у сильно похудевших людей; наблюдается и при расширении желудка (см. *Расширение желудка*).

**Симптомы и течение.** Ощущение полноты, тяжести и боли в животе, главным образом после еды и особенно после обильной. При лежании все эти явления проходят или ослабевают. При ходьбе и особенно при поднятии тяжестей боли усиливаются.

**Лечение.** Запрещается поднятие тяжестей. Необходимо постоянное ношение бандажа. При похудании — усиленное питание. Пить и есть почаще и небольшими порциями.

**ГASTРОЭНТЕРОКОЛИТ ОСТРЫЙ ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛУДКА И КИШОК (GASTROENTEROCOLITIS ACUTA).** Инфекция, испорченные (гнилые) пищевые продукты и другие ядовитые вещества поражают сначала слизистую желудка, а затем, проникая в кишечник, вызывают воспаление его слизистой оболочки.

**Симптомы и течение.** Сочетание признаков острого гастрита, энтерита и колита (рвота, понос, боли в животе, повышенная температура). В тяжелых случаях — коллапс (общая слабость, упадок сердечной деятельности, бледность покровов, похолодание конечностей). После устранения причины, вызвавшей болезнь, острые явления обычно проходят в течение нескольких дней, и постепенно наступает выздоровление. При тяжелых отравлениях больные погибают от общей интоксикации организма.

**Лечение** см. *Лечение острого гастрита, энтерита и колита.*

**ГЕЛЬМИНТОЗЫ** см. *Глистные заболевания.*

**ГЕМАТУРИЯ** см. гл. VI *Хирургические болезни.*

**ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА** см. *Анемия гемолитическая.*

**ГЕМОРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ.** Геморрагиями называются кровотечения, а диатез — это предрасположение организма к определенным заболеваниям. Геморрагическим диатезом, или кровоточивостью, называются заболевания, сопровождающиеся кровотечениями, возникающими вследствие понижения свертываемости крови, недостатка в крови тромбоцитов или повреждения капилляров (токсические или дистрофические). К геморрагическим диатезам относятся такие болезни, как тромбонения, гемофилия, цынга.

**ГЕМОРРОИ** см. гл. VI *Хирургические болезни.*

**ГЕМОТОРАКС** см. *Кровоизлияние в полость плевры.*

**ГЕМОФИЛИЯ. КРОВОТОЧИВОСТЬ (HAEMORPHILIA).** Болезнь наследственная, поражающая только мужчин. Кровоточивость объясняется понижением свертываемости крови.

**Симптомы и течение.** После хотя бы незначительного ранения или травмы (порез, царапина, удаление зуба, ушибы) следуют упорные кровоизлияния и кровотечение под кожу, в суставы, мышцы, из слизистых оболочек. Резкое понижение свертываемости крови. В резко выраженных случаях больные гибнут уже в детском возрасте, так как ребенка трудно уберечь от ушибов, царапин и других повреждений. После 20-летнего возраста кровоточивость ослабевает, а с старости может совершенно исчезнуть.

**Лечение.** Оберегать больного от всяких ушибов и ранений, самых ничтожных операций вплоть до выдергивания зубов. Общее укрепление организма (см. *Анемия*). При кровотечении — обычные методы остановки кровотечения: давящая повязка, тампонада, подкожное впрыскивание нормальной лошадиной сыворотки (до 100 мл), внутривенное введение хлористого кальция. При значительных кровотечениях прекрасный результат дает переливание больших количеств крови.

Пища, богатая витамином С. Как кровоостанавливающее средство хорошие результаты дает витамин К (по 0,01 два-три раза в день).

**ГЕПАТИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ) ПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ ОСТРЫЙ (HEPATITIS PARENCHIMATOSA ACUTA).** Развивается большей частью на почве инфекции кишечного или иного происхождения.

Различают первичные инфекционные острые паренхиматозные гепатиты (болезнь Боткина, болезнь Васильева-Вейля) и вторичные. Вторичные острые гепатиты возникают при различных инфекционных болезнях. Крупозное воспаление легких, возвратный тиф, сепсис иногда сопровождаются желтухой (паренхиматозным гепатитом). Причинами гепатитов могут быть различные токсины, поступающие в печень из кишечника по воротной вене, а также из общего тока крови по печеночной артерии. Отравления новарсено-лом (например, при лечении сифилиса), мышьяком, фосфором, хлороформом, ядовитыми грибами и пр. могут вызвать острый гепатит.

**Симптомы течения.** Основной симптом острых гепатитов — желтуха.

Симптомы и течение инфекционных острых гепатитов см. *Боткина болезнь и Васильева-Вейля болезнь*, гл. 11 *Инфекционные болезни*.

Симптомы вторичных гепатитов, а также токсических зависят от основных заболеваний. Симптомы желтухи во многом будут сходны с желтухой при болезни Боткина.

Наиболее остро и бурно протекает заболевание, известное под названием *острой дистрофии печени*, которая является злокачественной формой паренхиматозного гепатита. Тяжелые формы болезни Боткина иногда протекают с явлениями острой дистрофии печени (см.). Беременность, сифилитическая инфекция и алкоголизм могут иногда способствовать развитию острой дистрофии печени, которая протекает с высокой температурой, быстро развивается значительная слабость, больные часто впадают в бессознательное состояние и в течение нескольких дней погибают.

**Распознавание.** Дифференцировать приходится между первичными острыми гепатитами, вторичными и токсическими. Затем острые паренхиматозные гепатиты нужно дифференцировать с хроническими гепатитами (циррозами), сопровождающимися желтухой, и с механическими желтухами, вызванными закупоркой печеночного или желчного протока (желчным камнем) или их сдавленней (раковой опухолью, эхинококковым пузырем, сифилитической гуммой).

**Лечение** см. *Болезнь Боткина и Васильева-Вейля*. При вторичных и токсических желтухах лечение основного заболевания.

**ГЕПАТИТ СИФИЛИТИЧЕСКИЙ** см. *Сифилис печени*.

**ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ** см. *Циррозы печени*. **ГИГАНТИЗМ.** Передняя доля гипофиза выделяет гормон роста. Если повышенная функция передней доли гипофиза происходит в период роста (в детстве и юношестве), то наблюдается усиленный пропорциональный рост всего организма. Такой чрезмерный рост называется *гигантизмом*. Усиленный рост обычно начинается в период полового созревания. Гигантский рост доходит до 200—220 см и больше. Психическое и половое развитие у гигантов отстает. Мышцы плохо развиты, трудоспособность и половое чувство понижены. Гиганты недостаточно устойчивы к различным инфекциям

и часто погибают в молодом возрасте. Если болезнь начинается после окончания периода роста, то развивается акромегалия (см.).

**ГИДРОНЕФРОЗ** см. гл. VI *Хирургические болезни*. **ГИДРОТОРАКС (HYDROTHORAX).** Водянка грудной клетки. При этой болезни происходит скопление трансудата (невоспалительной жидкости) в полости плевры. Он появляется, наряду с общими отеками в других полостях и в подкожной клетчатке, при тяжелой сердечной недостаточности, нефритах и особенно нефрозах, алиментарной дистрофии.

**Симптом и течение.** Гидроторакс всегда начинается в нижних отделах полости плевры, одновременно с двух сторон, причем иногда с одной стороны жидкости может быть несколько больше. При перкуссии — притупление, при выслушивании — ослабленное дыхание или его отсутствие; ослабление голосового дрожания. В результате сдавления обоих легких значительно затрудняется работа сердца и появляются или усиливаются признаки сердечной недостаточности (одышка, цианоз, учащение и ослабление пульса). Температура и состав крови нормальны. Течение гидроторакса как осложнения одного из указанных выше заболеваний зависит от течения основной болезни.

**Распознавание.** Отличать нужно главным образом от выпотного плеврита и гемоторакса, которые обычно бывают односторонними.

**Лечение.** Лечение основного заболевания и сердечной недостаточности. Если трансудат достаточно велик и ухудшает состояние больного, его нужно выпустить.

**ГИПЕРТИРЕОЗЫ** см. *Базедова болезнь*.

**ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (MORBUS HYPERTONICUS).**

Гипертонической болезнью называется заболевание, основным симптомом которого является повышенное артериальное давление (гипертония).

Под гипертонией обычно подразумевают повышенный тонус кровеносных сосудов (мелких артерий), что и определяет повышение давления во всей артериальной системе. От гипертонической болезни следует отличать так называемую симптоматическую гипертонию, когда гипертония является только симптомом какого-либо другого заболевания, например, при воспалении почек, некоторых заболеваниях желез внутренней секреции и других болезнях.

**Причины болезни.** Возникновение гипертонической болезни объясняется перенапряжением коры головного мозга, резкими психическими переживаниями (психическими травмами). Раздражения высших нервных центров (коры головного мозга) через вегетативные нервные центры передаются на периферию, вызывая спазмы, сужение артерий (артериол).

Гипертоническая болезнь часто возникает у лиц с повышенной реактивностью центральной нервной системы. При дальнейшем течении болезни повышенный тонус сосудов, возможно, поддерживается различными прессорными веществами, выделяемыми органами внутренней секреции (адреналин, вазопрессин, гормон гипофиза и др.) и почками (ренин). Этим можно объяснить сравнительно ча-



стое возникновение гипертонической болезни у женщин в климактерическом периоде.

**Симптомы и течение болезни.** Основным симптомом этой болезни является повышенное артериальное давление. Повышенным считают такое давление, когда максимальное давление превышает 140 мм ртутного столба, а минимальное — 80 мм.

При гипертонической болезни максимальное давление может достигать до 200—300 мм, а минимальное — до 130—150 мм и даже выше. Пульс напряженный, сердце увеличено вследствие гипертрофии левого желудочка. На аорте выслушивается акцент второго тона. Больные жалуются на приливы к голове, сердцебиение, головокружение, боли в сердце, головные боли.

При гипертонии наблюдаются спазмы артериол; такие же спазмы могут происходить в венечных артериях и артериях головного мозга, чем и объясняются боли в этих органах.

Гипертоническая болезнь большей частью развивается постепенно, протекает хронически, годами, проходя ряд стадий. Различают три стадии болезни: преходящую (неустойчивую), устойчивую (постоянную) и склеротическую. В первой стадии болезни артериальное давление периодически повышается под влиянием каких-либо раздражающих нервную систему факторов, а затем падает до нормы. Во второй, устойчивой, стадии артериальное давление понижено, по дает снижение, даже временно падает до нормы под влиянием благоприятных условий внешней среды и соответствующего лечения. В третьей стадии болезни наблюдается устойчивая гипертония, дающая некоторые снижения давления, обычно не достигающие до нормы. Повышенный тонус стенок артерий и повышенное давление крови создают благоприятные условия для развития склеротических изменений и отложения холестерина в стенках артерий. Поэтому в третьей стадии болезни уже наблюдаются те или иные склеротические изменения в сосудах.

Различают три основные формы склеротической стадии гипертонической болезни: сердечную, мозговую и почечную. Редко наблюдаются эти формы в чистом виде. Практически встречается преимущественно сердечная, мозговая или почечная форма. Сердечная форма сопровождается приступами болей в сердце (стенокардия, грудная жаба).

Вследствие склероза коронарных сосудов они суживаются, и питание сердечной мышцы нарушается (коронарная недостаточность). В гипертрофированной мышце развиваются дистрофические, а затем склеротические изменения, вызывающие постепенное ослабление сердечной мышцы, и к основной болезни присоединяются явления сердечной недостаточности — одышка, отеки и приступы сердечной астмы. Склероз венечных артерий при наличии приступов стенокардии может закончиться тромбозом их, т. е. инфарктом миокарда. Больные погибают от инфаркта или от нарастающих явлений сердечной недостаточности. При мозговой форме, при склерозе мозговых сосудов головные боли становятся более постоянными, головокружение усиливается; слабеет память, больные теряют трудоспособность. Они могут погибнуть от кровоизлияния в мозг.

При почечной форме, склерозе мелких почечных артерий (нефроангиосклероз) нарушается функция почек с развитием их недостаточности, которая постепенно заканчивается уремией.

Иногда наблюдается быстро прогрессирующий артериолосклероз почек. Такая быстро развивающаяся почечная форма гипертонической болезни называется злокачественной.

**Распознавание.** На основании повышения артериального давления, напряженного пульса, увеличения сердца влево и вниз, акцента второго тона на аорте и других указанных выше симптомов.

Из анамнеза выяснить, не является ли гипертония вторичной, развившейся вследствие бывшего воспаления почек или других заболеваний, сопровождающихся повышенным артериальным давлением.

**Лечение.** Устранение причин, вызвавших гипертонию. В различной стадии болезни требуется и различное лечение.

В первой стадии лечение заключается главным образом в воздействии на нервную систему. Больные в этой стадии трудоспособны и лечатся амбулаторно. При повышенной возбудимости нервной системы надо создать для больного соответствующую обстановку. Работа должна протекать в спокойной обстановке с достаточным отдыхом. Больным запрещают чрезмерную умственную работу, связанную с нервным напряжением, алкоголь, курение, крепкий кофе и чай.

Больным следует запретить и тяжелую физическую работу. Диету назначают преимущественно молочно-растительную. Запрещаются соленые и острые продукты (закуска, копчености, маринады и пр.), ограничивается питье. Больные не должны много есть и пить за один прием, надо следить за правильным функционированием кишечника.

Для укрепления нервной системы большое значение имеют занятия физкультурой, водные процедуры, отдых в санатории и пр.

Из лекарственных средств назначают успокаивающие: валериану, ландышевые капли, бром, люминал и хлоралгидрат в небольших дозах.

Rp. Inf. rad. Valerianae ex 6,0—200,0 Natrii bromati 6,0  
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. T-rae Valerianae simpl.  
T-rae Convallariae majalis aa 10,0 MDS.  
По 20 капель 3 раза в день

Rp. Luminal) 0,05  
D. t. d. N. 6 in tab.  
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp. Chlorali hydrati 2,0  
Micilaginis Gummi arabici •  
Aq. destillatae aa 50,0  
MDS. По 1 столовой ложке 2 раза в день

Режим и лечение, применяемые при первой стадии, продолжают и во второй. При значительном возбуждении и плохом сне, помимо успокаивающих средств, назначают снотворные.

По словам И. П. Павлова, во время сна кора головного мозга приходит в тормозное состояние, остается «свободной от работы» и «восстанавливает свой нормальный состав». Поэтому и гипертоническую болезнь теперь иногда лечат длительным сном. Дают различные снотворные: веронал, люминал, хлоралгидрат, барбамил, проводят условнорефлекторный сон.

Up. Vii'onali 0,5 D. t.  
d. N. 3  
S. 1 порошок за час до сна в полстакан  
горячей воды

Rp. Barbamyli 0,3 D. t. d. N. 6 S. По 1  
порошку 3 раза в день

Лечение длительным сном можно проводить только в больничных условиях.

Кроме успокаивающих и снотворных, назначают средства, понижающие кровяное давление (диуретин, папаверин, сальсолин, платифиллин).

Rp. Camphorae monobromatae 0,2  
Papaverini hydrochlorici 0,02 M. f.  
pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку  
3 раз в день

Rp. Diuretini 0,3  
Lumiuali  
Papaverini hydrochlorici aa 0,02  
M. i. pulv. D. t. d. N. 10 «  
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Salsolini hydrochlorici 0,03  
Sacchari 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1  
порошку 3 раза в день

Rp. Platyphyllini bitartarici 0,003  
Sacchari 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1  
порошку 3 раза в день

Хорошее действие оказывает новое средство дибазол,

Rp. Dibazoli 0,02  
Sacchari 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1  
порошку 3 раза в день

При климаксе назначают синэстрол или фолликулин.

Rp. Folliculini 1,0  
D. t. d. N. 30 in amp.  
S. По 1 ампуле под кожу ежедневно

Rp. Synestroli 0,001  
D. t. d. N. 12 in tab.  
S. По 1 таблетке 2 раза в день (в течение 20—25 дней)

При значительном повышении артериального давления периодически ставят пиявки или делают кровопускание.

В третьей стадии, кроме указанных мероприятий, проводят лечение атеросклероза, нефроангиосклероза и всех других патологических явлений, наблюдающихся в этой стадии (стенокардия, сердечная астма, инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность (см.).

**ГИПОТИРЕОЗЫ** см. *Микседема*.

**ГИПОТОНИЯ** см. *Сердечно-сосудистая недостаточность*.

**ГЛИСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ** (см. также гл. V *Детские болезни*).

#### Лечение взрослых

**Аскаридоз** (поражение аскаридами). За день до начала лечения назначается легкая нежирная пища, вечером дается слабительное, \*лучше всего слабительные соли (английская или глауберова соль).

Rp. Magnesii sulfurici 30,0  
DS. На прием в полстакане теплой воды

Сантонин дают утром натощак или после легкого завтрака (стакан чаю и небольшой кусочек хлеба) в три приема — через час по таблетке. Через час после последней таблетки снова слабительное. Такое лечение проводят два дня подряд. Можно давать сантонин и в течение всего дня: утром — после легкого завтрака, за 1 час до обеда и за 1 час до ужина с последующей дачей слабительного. Через две недели производят исследование кала на яйца глистов и в случае положительного результата проводят повторный курс лечения.

Rp. Santonini 0,1  
D. t. d. N. 9 in tab/ S. По одной  
таблетке 3 р.-за в день »

Можно давать готовые таблетки санкафен, которые, кроме сантонина, содержат слабительные каломель и фенолфталеин (сантонина и фенолфталеина по 0,016 и каломели 0,0065). Накануне вечером ставят клизму, а утром натощак в течение получаса дают 8—10 таблеток. Санкафен тоже дают 2 дня подряд.

Иногда против аскарид дают цитварное семя — 2,0—4,0 на прием обычно с вареньем или медом; три-четыре раза в день. Хорошее действие оказывает гоксилрезорцин.

Rp. Hexylresorcini 0,2

D. t. d. in caps, geloduratis N. 5 S. Принять всю дозу утром натощак по 1 капсуле каждые 5 минут

Накануне вечером и через 12 часов после приема лекарства — слабительное. После приема лекарства пятичасовое голодание.

Трихоцефалеа (поражение власоглавом). Лучшим средством является осарсол.

Rp. Osarsoli 0,25

D. t. d. N. 20 in tab.

S. По 1 таблетке за 1 час до еды 4 раза в день (давать 5 дней по 4 таблетки)

Больной накануне получает легкую диету, вечером слабительное. В конце лечения опять слабительное. Через две-три недели в случае надобности курс лечения повторяют.

Заболевания печени и почек являются противопоказанием и даже осарсола.

Кроме осарсола, дают тимол.

Rp. Thymoli 0,5

D. t. d. N. 7 in capsulis

S. По 1 капсуле натощак за полчаса до еды

Курс лечения — 7 дней. Вечером седьмого дня слабительная соль 30,0 на прием. После семидневного перерыва повторно лечение. Проводят 8 таких курсов. Тимол противопоказан при болезнях почек, печени, острых и явных желудочно-кишечных воспалениях и при беременности.

Трихинеллез. Трихина, или трихинелла, тоже относится к круглым червям. Трихинеллы встречаются у многих животных, в том числе у свиней, собак, крыс. Заражают они и человека. Один и тот же организм может быть окончательным и промежуточным хозяином для трихинелл.

Заражение происходит через свиное мясо, в котором находятся трихинозные зародыши. Свиньи заражаются от крыс, которых они поедают. Крысы в свою очередь заражаются от всякой падали, в которой находились трихины.

Трихины — маленькие червячки длиной 3—4 мм. Личинки трихинелл со свиным мясом попадают в желудок; мясо там переваривается, капсула личинок разрушается. В таком виде личинки переходят в кишечник, где в течение двух суток превращаются в зрелых трихинелл. Трихинеллы проникают в стенку кишечника и за 1—2 месяца откладывают до 1 500 личинок; личинки с током крови разносятся по всему организму. Они проникают в поперечнополосатые мышцы, преимущественно в мышцы диафрагмы, гортани, жевательные, межреберные.

Заболевание трихинеллезом протекает очень тяжело и сравнительно часто кончается смертью. В начале болезни наблюдаются желудочно-кишечные явления: резкие боли в животе, рвота, поносы с водянистыми испражнениями. Температура,

вследствие отравления токсинами, доходит до 40°. Когда трихины проникают в мышцы, появляются резкие мышечные боли.

В крови лейкоцитоз за счет увеличения эозинофилов, число которых доходит до 40, СО и даже 80%. Болезнь продолжается в течение нескольких недель, затем наступает медленное выздоровление.

Особенно вначале, а также в течение всей болезни дают слабительные соли, так как самки живут в кишечнике до месяца и более. Назначают также каломель.

Rp. Calomelaus 0,15

Sacchari 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 5 • S. По 1 порошку через час до действия

Через 2 часа после приема последнего порошка дают слабительные соли.

Слабительные назначают для того, чтобы очистить кишечник от трихин и личинок, которые еще не успели проникнуть из кишечника в мышцы.

Общий уход такой же, как за тяжелыми лихорадящими больными.

При ослаблении сердечной деятельности назначают соответствующие сердечные средства.

Цестодоз (поражение ленточными глистами). Накануне лечения — легкая диета с острыми приправами: селедка, лук, чеснок, "вечером солевое слабительное. На следующее утро натощак экстракт мужского папоротника.

Rp. Extr. Filicis maris aetherei 0,5

D. t. d. N. 12 in capsulis gelatinosis S.

Принять в течение получаса

Через 1—2 часа после последней капсулы — слабительная соль 30,0 на прием (касторовое масло противопоказано).

Еще эффективнее вводить экстракт папоротника непосредственно в двенадцатиперстную кишку через дуоденальный зонд одновременно со слабительной солью.

Rp. Extr. Filicis maris aetherei 6,0

Gummi arabici q. s. ut -fiat, emulsio 50,0 J)S. Ввести через дуоденальный зонд. Через 15—30 минут через тот же зонд ввести раствор английской соли (30,0 на полстакана воды), после чего зонд извлечь

После выхождения солитера или действия слабительного больному нужно дать легкий горячий завтрак и обильное питье (кофе, чай).

Так как изгнание ленточных глистов ослабляет больного, а кроме того, возможно отравление папоротником, лечение нужно проводить в постели и под наблюдением медицинского персонала. Через лупу надо осмотреть узкий конец солитера, чтобы проверить, вышла ли его головка. В противном случае через несколько месяцев

повторяют лечение. Для изгнания солитеров с хорошим успехом применяют тыквенное семя (100—300 г на прием).

Энтеробиоз (поражение острицами) см. гл. V *Детские болезни, Глистные заболевания.*

**ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ** см. *Высотная болезнь.*

**ГРУДНАЯ ЖАБА** см. *Стенокардия.*

**ДЕКОМПЕНСАЦИЯ СЕРДЦА** см. *Сердечно-сосудистая недостаточность.*

**ДИАБЕТ НЕСАХАРНЫЙ, НЕСАХАРНОЕ МОЧЕИЗЖУРЕНИЕ (DIABETES INSIPIDUS).** Несахарное мочеизжурение возникает вследствие понижения функции задней доли гипофиза (мозгового придатка), выделяющего тормозящий мочеотделение гормон. Играет роль и центральная нервная система (межучетный мозг). Причинами поражения гипофиза и межучетного мозга являются опухоли, травма головного мозга, сифилитическая и туберкулезная инфекция.

**Симптомы и течение.** Усиленное выделение мочи (до 10—30 л мочи в сутки) с очень низким удельным весом (1,001—1,004), жажда. Состав мочи нормальный. Болезнь хроническая (продолжается годами).

**Распознавание.** Нужно отличать от сахарного диабета, при котором наблюдается высокий удельный вес мочи и содержание сахара в ней; нужно иметь в виду болезни, при которых наблюдается полиурия, например, при сморщенной почке (начальная стадия хронического нефрита и нефроангиосклероза).

Лечение. Наиболее эффективно применение антидиуретического гормона питуитрина Р (задняя доля гипофиза) и адиурекрина.

Нр. Pituitrini 1,0

, D. t. d. N. 6 in amp.

S. Ежедневно по 1 мл под кожу

Рр. Adiurect'ni 0,05

D. t. d. N. 10

S. Но 1 порошку вводить в нос 1—2 раза в день

Пища, бедная солью и белками (чтобы уменьшить жажду). Питье нельзя ограничивать, — но больной сам должен стремиться к воздержанию от него. Общеукрепляющее лечение.

**ДИАБЕТ САХАРНЫЙ. САХАРНОЕ МОЧЕИЗЖУРЕНИЕ (DIABETES MELLITUS).** При сахарном мочеизжурении нарушается углеводный обмен — недостаточное усвоение сахара организмом, увеличение образования сахара, выведение сахара с мочой; повышение количества сахара в крови. Главной причиной сахарной болезни является понижение функции поджелудочной железы (уменьшение образования инсулина). В развитии сахарного диабета большое значение имеет состояние первой системы. Болезнь иногда возникает после сильных нервных потрясений, травм головного мозга. Возможно что нервная система действует на углеводный обмен через поджелудочную железу, т. е. предварительно вызывает понижение ее функции. Чрезмерное переедание, чрезмерное употребление сладких, мучнистых и сдобных блюд предрасполагают к сахарной болезни.

**Симптомы и течение.** Повышенная жажда, увеличение выделения мочи (до 3—5 л и более в сутки). Основной признак — присутствие сахара в моче. Удельный вес мочи всегда высокий (до 1 030—1 050). Повышенное количество сахара в крови, повышенный аппетит в начале болезни; затем появляется общая слабость, быстрая утомляемость, повышенная нервная возбудимость, похудание и малокровие. В тяжелых случаях при недостатке в тканях углеводов из жиров и белков образуются ацетоновые тела, отравляющие организм, что приводит к диабетической коме: глубокое шумное дыхание (большое дыхание Кусмауля), запах ацетона (похожий на запах вблос) от выдыхаемого воздуха; падение сердечной деятельности и артериального давления; потеря сознания.

Различают легкую и тяжелую форму диабета. При легкой форме сахар в моче исчезает при ограничении углеводной пищи. При тяжелой форме диабета сахар имеется в моче постоянно, даже если пища совсем не содержит углеводов.

Легкие формы сахарной болезни могут тянуться годами, не особенно беспокоя больных.

При тяжелых формах наступает изжурение и истощение, всего организма, вследствие чего могут развиваться вторичные заболевания: фурункулез, карбункулы и особенно туберкулез легких, от которого больные часто гибнут. В некоторых случаях болезнь оканчивается диабетической комой, от которой больные погибают, если не принять соответствующих мер (впрыскивание инсулина).

**Распознавание.** На основании постоянной жажды, полиурии, высокого удельного веса и сахара в моче, а также повышенного содержания сахара в крови.

Нужно отличать от песахарного диабета и других заболеваний, при которых наблюдается полиурия (хронический нефрит, нефро-ангиосклероз).

**Лечение.** Индивидуальный стол. Нужно установить, каково углеводы больной лучше переносит и при каком количестве углеводов сахар исчезает из мочи или заметно уменьшается его количество. Питание должно быть полноценное, с достаточным содержанием белков, жиров, углеводов и витаминов, особенно для истощенных больных. Диабетические стрлы должны содержать в среднем от 200 до 500 г углеводов, от 85 до 130 г белка, от 70 до 100 г жиров с общим количеством калорий от 2 000 до 3 000. Для тучных больных устанавливают разгрузочные овощные или фруктовые дни (2 кг свежих огурцов и 1 кг капусты, 1,5 кг яблок и пр.). Когда диетой нельзя добиться полного исчезновения сахара в моче, применяют инсулин по 10—20 единиц под кожу 1—2 раза в день, одновременно увеличивая в рационе количество вводимых углеводов (200 г хлеба или какой-либо каши и пр.). Инсулин обычно впрыскивают за 1—2 часа до еды. В тяжелых случаях нельзя резко снижать количество даваемых углеводов, чтобы предупредить возникновение диабетической комы.

При значительном истощении больного и накоплении в крови кетоновых тел (ацетона, ацетоуксусной кислоты) больного надо усиленно кормить и давать достаточное количество углеводов. Для усвоения последних вводят большие количества инсулина — до

80—90 единиц в сутки. При коме инсулин вводят в виде инъекций в дозах до 200 единиц в сутки.

С большими дозами инсулина одновременно вводят внутривенно глюкозу, чтобы не вызвать гипогликемии (уменьшение содержания сахара в крови ниже нормы). При гипогликемии появляется чувство голода, общая слабость, значительная потливость, дрожание конечностей и всего тела, учащенный пульс, иногда кома, при которой больной может погибнуть. При гипогликемии надо прекратить дачу инсулина и дать больному несколько кусочков сахара или хлеба. При наступлении комы ввести внутривенно 20—50 мл 40% глюкозы.

Всякое переутомление и возбуждение нервной системы увеличивают количество сахара в моче, поэтому для общего укрепления организма и для отдыха больных направляют в санатории и на курорты. Больным назначают щелочи, минеральные щелочные воды, так как у больных диабетом образуются кислые продукты (кетонные тела), вызывающие отравления организма. Неистощенным, особенно тучным, больным показан легкий физический труд, занятия спортом и лечебной гимнастикой. При развитии малокровия, фурункулов, ослаблении сердечной деятельности необходимо соответствующее симптоматическое лечение.

Надо следить за весом больного, не допускать истощения больного, страдающего диабетом.

При истощении больного необходимо более полноценное питание; одновременно следует назначать соответствующие дозы инсулина. С целью профилактики и своевременного лечения на каждого больного диабетом составляется особая карточка. Все больные находятся под постоянным наблюдением поликлинического врача.

**ДИСПЕПСИЯ БРОДИЛЬНАЯ.** **ДИСПЕПСИЯ ГНИЛОСТНАЯ** см. *Поносы.*

**ДИСТРОФИЯ АЛИМЕНТАРНАЯ** см. *Алиментарная дистрофия.*

**ДИСТРОФИЯ МИОКАРДА** см. *Миокардиодистрофия.*

**ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ ОСТРАЯ** см. *Болезнь Боткина. Гепатит паренхиматозный острый.*

**ЖЕЛТУХА.** Желтуха — не болезнь, а синдром (совокупность симптомов), наблюдаемый при различных заболеваниях печени, закупорке желчных протоков, интоксикациях, повышенном распаде эритроцитов (гемоллизе).

При воспалении печени бывает поражение печеночной паренхимы. Воспаленные печеночные клетки теряют способность выделять пигменты в желчные протоки. Желчные пигменты, проникая в кровь, вызывают желтуху.

Желтуха, развившаяся вследствие воспаления самой печеночной паренхимы, называется *паренхиматозной желтухой* (см. *Гепатит паренхиматозный острый*).

Если крупный желчный проток будет закупорен желчным камнем или сдавлен раковой опухолью, то тоже развивается желтуха. Желтуха, вызванная механическим препятствием, называется *механической желтухой*.

**Паренхиматозная механическая желтуха**, развивающаяся вследствие болезни печени или закупорки желчных протоков, называется *гепатогенной*.

При всякой гепатогенной желтухе кожа и белочная оболочка глаз окрашиваются в желтый цвет, причем вначале заметно окрашивание глаз, а затем кожи. При продолжительной желтухе, особенно механической, кожа приобретает зеленоватый (шафранный) и даже черный оттенок. Затем наблюдается ряд других болезненных явлений. Ввиду отсутствия в кишечнике желчи испражнения светлые, глинистого цвета, с непереваренным жиром. Желчь не только участвует в переваривании жиров — она дезинфицирует кишечник и усиливает его перистальтику. Поэтому при желтухе обычно наблюдается запор; испражнения и газы/образующиеся в большом количестве, часто сопровождаются гнилостным запахом.

Желчь, циркулирующая в крови, действует отравляющим образом на весь организм. У больных появляется упадок сил, подавленное настроение, головные боли, пульс становится редким. Если желтуха длится долго, то, вследствие раздражения желчью нервных окончаний кожи, возникает сильный зуд, иногда очень беспокоящий больного.

Из организма желчь выделяется мочой, поэтому моча приобретает темную окраску; цвет мочи в отличие от нормальной окрашивается в желтый цвет. Если моча попадает на белье, на нем остаются зеленовато-желтые пятна.

**Гемолитическая желтуха** в отличие от гепатогенной развивается вследствие повышенного распада красных кровяных телец (гемолиз), в результате чего освобождается большое количество гемоглобина. Как известно, красящее вещество желчи — билирубин — образуется из гемоглобина крови. При повышенном образовании билирубина желчь насыщена желчными пигментами.

В кишечнике из билирубина образуется большое количество гидробилирубина, значительная часть которого, всасываясь из кишечника в кровь, поступает обратно в печень. Излишек его поступает в общий ток крови. В результате этого появляется желтушное окрашивание кожи и склер.

Из сказанного видно, что гемолитическая желтуха — заболевание крови, а не печени (см. *Анемия гемолитическая*).

При гемолитической желтухе кожа и склеры окрашены в лимонно-пожелтый цвет. В отличие от гепатогенных желтух при гемолитической испражнения интенсивно окрашены в амнокоричневый цвет вследствие повышенного поступления в кишечник билирубина.

При гемолитической желтухе не наблюдается кожного зуда и других явлений интоксикации организма.

**ЖЕЛТУХА ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ** см. *Анемия гемолитическая.*

**ЖЕЛТУХА ИНФЕКЦИОННАЯ** см. *Болезнь Боткина. Гепатит паренхиматозный острый*, гл. 11. *Инфекционные болезни*

**ЖЕЛТУХА КАТАРРАЛЬНАЯ** см. *Болезнь Боткина. Гепатит паренхиматозный острый.*

**ЖЕЛТУХА МЕХАНИЧЕСКАЯ** см. *Желтуха.*

**ЖЕЛТУХА СПИРОХЕТНАЯ** см. *Инфекционная желтуха*, гл. II. *Инфекционные болезни.*

**ЖЕЛУДОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ** см. *Кровотечение желудочное.*

**ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (CHOLELITHIASIS).** Желчные камни образуются в желчном пузыре и желчных протоках. Главной причиной их образования является нарушение холестеринового обмена (повышенное содержание холестерина в крови, а также в желчи). Имеет значение также застой желчи в желчном пузыре и желчных протоках, постоянные запоры со вздутием кишечника, тучность, переедание. Воспалительные процессы в желчном пузыре (холецистит) и желчных протоках (холангит) способствуют образованию камней. Нарушение нервной регуляции в образовании желчи, деятельности печени и желчных путей имеет первенствующее значение в развитии желчнокаменной болезни.

**Симптомы и течение.** Основной признак — приступы резкой боли в правом подреберье (печеночные колики). Характерна отдача болей в правую лопатку. Приступы болей появляются от рефлекторно возникающих спазмов гладкой мускулатуры желчного пузыря и особенно желчных протоков. Печеночная колика часто сопровождается рвотой, ознобом и повышением температуры. Если камень закупорил главный печеночный или желчный проток, может развиваться желтуха (механическая). При пальпации печень резко болезненна, особенно в области желчного пузыря. Приступ может продолжаться несколько минут, часов или даже несколько дней. После приступа больной в течение нескольких дней чувствует тяжесть или небольшую боль в области печени. Иногда температура держится довольно долго вследствие воспаления желчного пузыря и протоков. Если воспаление приняло гнойный характер, болезнь принимает тяжелую форму с послабляющей температурой, причем может произойти прободение желчного пузыря в полость брюшины. Желтуха может быстро пройти или же упорно держаться. Приступы печеночной колики могут годами не повторяться или следовать один за другим очень часто.

Иногда желчнокаменная болезнь ничем себя не проявляет или дает нерезко выраженные признаки хронического холецистита без приступов печеночной колики.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Желчнокаменную болезнь приходится отличать от холецистита и холангита без наличия камней от различных заболеваний, характеризующихся приступами болей (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендицит, почечнокаменная болезнь); при наличии желтухи — от острых гепатитов, циррозов, рака и эхинококка печени.

**Л е ч е н и е.** Во время приступа печеночной колики — под кожу морфия или омнопон (пантопон) или еще лучше морфин вместе с атропином.

Rp. Sol. Alorphini hydrochlorici! 1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 0,5—1 мл 1—2 раза в сутки под кожу

Rp. Sol. Omnoponi 2% 1,0 J. t. A. N. 6 in amp. S. По 1 мл 1—2 раза в сутки под кожу

Rp. Morphini hydrochlorici 0,1  
Atropini sulfurici 0,01 Aq  
d.still. 10,0 Strilisetur!

MDS. По 0,5—1 мл под кожу Полный покой, согревающий компресс или грелка на область печени, теплые или горячие ванны. При гнойном холецистите — полный покой и лед на область пузыря. Когда резкие боли стихают, дают слабительное, лучше каломель, с последующим приемом касторового масла или слабительных солей (английская соль).  
Rp. Calomelanos 0,15 Sacchari 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 5 S. По 1 порошку через час до действия. Через 2 часа после последнего порошка дать слабительное

Затем лечение, как при гепатитах и холециститах (<и.). Между приступами назначают молочно-растительную диету. Следить за действием кишечника, принимать щелочные воды (эссендуки, боржом). Из курортов рекомендуются Эссендуки. При частых приступах и упорной желтухе, а также при гнойном воспалении желчного пузыря — операция (удаление камня вместе с желчным пузырем).

**ЗАПОРЫ (OBSTIPATIO).** Причины: механические препятствия в различных отделах кишечника (рубцовые сужения, опухоли, геморроидальные узлы); замедление кишечной перистальтики как результат ослабления кишечной мускулатуры (атония кишок). Атония кишок развивается при ослаблении общего тонуса организма, иногда под влиянием психических воздействий, при значительном малокровии и похудании вследствие длительных инфекционных заболеваний; при ослаблении брюшных мышц, сидячем образе жизни: при питании легкой, хорошо усваиваемой пищей, почти не дающей остатков (мясо, яйца, сахар, молочные продукты). Злоупотребление клизмами и слабительными приводят к атоническим запорам. Частое подавление желаний (рефлекса) к акту дефекации и его отсрочка приводят к развитию так называемых привычных (атонических) запоров. Кроме атонических, наблюдаются еще спастические запоры, вызываемые длительными сокращениями круговых мышц кишечника. В развитии кишечных спазмов большую роль играет перераздражение вегетативной нервной системы. Различные психические переживания могут вызывать спазмы кишечника (через вегетативную нервную систему). При воспалительных явлениях в кишечнике запор может быть симптомом болезни (например, хронического колита). В этих случаях спазмы возникают от рефлексов, идущих со слизистой кишечника.

**Симптомы и течение.** Редкие испражнения — через день, два и реже. Кал твердый, темного цвета; иногда в виде отдельных орешков (овечий кал). Иногда стул бывает ежедневно и даже несколько раз в день, но небольшими порциями, так что кишечник полностью не очищается. При кишечных спазмах наблюдаются боли в животе. Иногда — вздутие кишечника газами, сопровож-

дающееся болями; после отхождения газов боли проходят. Застой каловых масс в кишечнике усиливает процессы гниения, постепенно ведет к воспалению (хронический колит). Отравление организма гнилостными продуктами развивает общую слабость и малокровие о головными болями, плохим настроением.

**Распознавание** на основании приведенных признаков. Важно установить, имеется ли только нарушение функции кишечника или одновременно и воспалительные изменения (хронический колит).

**Лечение.** При атонических запорах развивать кишечную и брюшную мускулатуру (занятие физкультурой, больше двигаться). При здоровом кишечнике — грубая и молочно-растительная пища; черный хлеб, овощи, фрукты, ягоды, гречневая каша, молоко, простокваша и пр. Привычные запоры устраняются путем выработки условного рефлекса к опорожнению кишечника: в определенное время, лучше всего по утрам, делают попытки опорожнить кишечник. При спастических запорах: избегать нервного переутомления, создать спокойную обстановку в работе и быту, заниматься физкультурой, не курить, не употреблять алкогольных напитков; иногда полезно принимать средства, успокаивающие нервную систему (бром, валериана, люминал). При спазмах хорошее действие оказывает атропин. Механические запоры лечат устранением механических препятствий. В некоторых случаях приходится прибегать к очистительным клизмам или слабительным — внутрь вазелиновое масло (по 1 столовой ложке за полчаса до еды 2 раза в день).

Если его действие недостаточно, дают ревеня, сложнolakрич-ный порошок, карлсбадскую соль, фенолфталеин (пурген), фрай-гулен.

Rp. Pulv. rad. Rhei 0,5 D. t. d. N. ti S. По 1 порошку 1—2 раза в день при запорах

Rp. Pulv. Liquiriti compositae 50,0 \*

DS. 1 чайную ложку на полстакана теплой воды Припить на ночь

Rp. Phenolphthaleini 0,1—0,3 ft. d. N. 6 S. По 1—2 порошка на прием

Rp. Salis Carolini factitii 50,0  
DS. 1 чайную ложку на стакан воды.  
Выпить в течение 15 минут натощак

Rp. Franguleni 30,0  
DS. 1—2 чайных ложки на ночь

Если эти средства не помогают, приходится прибегать к более сильнейшим слабительным (касторовому маслу, английской или глауберовой соли), сифонным клизмам или даже механическим путем (пальцем) удалять из прямой кишки каловые массы («каловые камни»).

**ЗОВ ЭНДЕМИЧЕСКИЙ (STRUMA ENDEMICA).** Зоб наблюдается в определенных ограниченных местностях. Развитие зоба объясняют недостаточным количеством иода в питьевой воде и пищевых продуктах. Иод необходим для правильной функции щитовидной железы. **Симптомы и течение.** Основным симптом — увеличенная щитовидная железа (зоб), которая может достигать до величины головы взрослого человека. Большой зоб иногда стесняет дыхание. Функция щитовидной железы может быть повышена (гипертиреоз) (см. *Бааедсва болезнь*) или понижена (гипотиреоз) (см. *Микседема*). Если с раннего детства отмечается резкое понижение функции щитовидной железы, то\* развивается кретинизм, при котором наблюдаются зобатость, задержка роста и отсталость в умственном развитии (вялость, лень, слабоумие); кожа одутловатая, половые органы недоразвиты. Течение болезни хроническое.

**Лечение.** Постоянно принимать малые количества иода. Rp.

Jodi pun 0,2 ■ Kalii iodati 0,4 Aq destili 20,0 MDS От 5 до 10 капель 3 раза в день после еды

В местностях, где наблюдается эндемический зоб, с профилактической и лечебной целью снабжают население йодированной солью (обычная поваренная соль с незаметным на вкус количеством иода). При гипотиреозах, особенно кретинизме, постоянные приемы тиреоидина (по 0,1 три раза в день) с раннего детства. В остальном лечение общеукрепляющее.

Большие зобы, нарушающие функции органов шеи, удаляют хирургическим путем.

**ИНФАРКТ ЛЕГКОГО (INPARCTUS PULMONIS).** Возникает чаще всего от закупорки ветви легочной артерии тромбом, образовавшимся в правом отделе сердца или в венах большого круга кровообращения. Тромбы чаще всего образуются у больных с пороками сердца и кардиосклерозом, вследствие венозного застоя крови при сердечной недостаточности.

**Симптомы и течение.** Резкая боль в области инфаркта при дыхании, одышка, кашель с кровянистой мокротой. При значительном инфаркте — притупление перкуторного звука, бронхиальное дыхание, влажные хрипы, крепитация и часто шум трения плевры (в воспалительный процесс вовлекается и плевра, прилежащая к больному участку). Иногда развивается и выпотной плеврит. Воспалившийся инфаркт обычно сопровождается повышением температуры.

**Лечение.** Полный покой, приподнятое положение, свежий воздух в помещении. Больному запрещаются резкие движения в постели, разговоры, волнение, а также курение. При сильном кашле и болях — согревающий компресс. Внутрь наркотические средства (кодеин, дионин). При резкой боли и одышке — морфин или омнопон.

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici' 1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. 0,5—1 мл 1—2 раза в сутки под кожу

- Rp. Sol. Omnoponi 2% 1,0 D. t. d. N 6 in amp. S. По 1 ампуле 1—2 раза в сутки под кожу
- Rp. Codeini puri 0,015  
Sacchari 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Sol. Dionini 2% 15,0  
DS. По 15 капель 3 раза в день

При значительном кровохаркании — хлористый кальций внутрь или внутривенно; при ослаблении сердечной деятельности — камфора, кофеин.

- Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 200,0  
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
- Rp. Coffeini natrio-benzoici 0,2 D. t. d. N. 10  
S. По 1 порошку 3 раза в день
- Rp. Ol. camphorati 20% 2,0 D. t. d. N. 12 in amp. S. Для подкожного впрыскивания по 2 мл 3 раза в день

При воспалительных явлениях в легком с высокой температурой — сульфаниламидные препараты (см. *Пневмония крупозная*) и пенициллин (см. *Абсцесс легких*). При сильной одышке и цианозе — кислород и сердечные средства.

**ИНФАРКТ МИОКАРДА (INFARCTUS MYOCARDII).** Инфаркт миокарда образуется при закупорке (тромбозе) венечных артерий вследствие их склероза и спазма; чаще он является следствием дальнейшего развития стенокардии (см.). Иногда инфаркт возникает внезапно у человека, до этого никогда не жаловавшегося на заболевание сердца. Атеросклеротические изменения в венечных (коронарных) сосудах ведут к постепенному сужению их просвета; измененные стенки артерии способствуют образованию тромба (свернувшийся сгусток крови), который может совершенно закрыть просвет (коронаротромбоз). Так как венечные (коронарные) артерии имеют строение концевых артерий, то при их закупорке, вследствие нарушения питания в данном участке миокарда, образуется инфаркт, т. е. омертвление соответствующего участка миокарда; мышечная ткань на месте инфаркта постепенно перерождается, омертвевает и замещается соединительной тканью с последующим образованием рубцов.

**Симптомы и течение.** При тромбозе крупной ветви может наступить моментальная смерть. При тромбозе более мелких венечных сосудов развивается приступ грудной жабы, тяжелый и длительный (в течение нескольких часов и даже дней) (см. *Стено-*

*кардия*). Иногда боли ощущаются и в области сердца, а преимущественно в подложечной области. Часто инфаркт миокарда сопровождается приступом сердечной астмы. На следующий день поднимается температура, появляется лейкоцитоз (рассасывание некротического очага). При развитии инфаркта может возникнуть перикардит (см.). Если инфаркт образовался в передней стенке миокарда, то можно прослушать шум трения перикарда. Инфаркт протекает тяжелее стенокардии. При наступлении инфаркта известная часть сердечной мышцы выключается из работы, поэтому часто наступает острая сердечно-сосудистая недостаточность: бледность покровов, иногда с явлениями цианоза, ослабление и учащение пульса, падение кровяного давления, одышка. Иногда инфаркт миокарда протекает без болей в сердце, но с явлениями острой сердечно-сосудистой недостаточности. Сердечная мышца у человека, перенесшего инфаркт миокарда, остается неполноценной. Возможны повторные образования инфарктов.

**Распознавание.** Следует отличать от приступа стенокардии. Трудно установить, имеется ли только приступ стенокардии или же одновременно и инфаркт. Часто приступ болей (ангиозный приступ) продолжается несколько часов, а иногда не оставляет больного и несколько дней. Для инфаркта характерны длительные боли, продолжающиеся в течение нескольких часов, а иногда и дней, которые не прекращаются и после дачи нитроглицерина, повышение температуры, лейкоцитоз и в некоторых случаях шум трения перикарда.

Для диагностики инфаркта миокарда большое значение имеет электрокардиографическое исследование, которое позволяет даже определить его расположение. По электрокардиограмме можно также судить о степени заживления пораженной ткани, о рубцевании инфаркта.

**Лечение.** В остром периоде то же, что и во время приступа стенокардии. Больному особенно необходим покой, постельный режим в течение 1/а—2 месяцев, даже если пройдут все болезненные явления. Следует оградить больного от всяких возбуждений и волнений. Во время припадка — пиявки на область сердца, горячие ручные и ножные ванны, нитроглицерин 2—3 капли (желательно на кусок сахара, сосать), впрыскивания атропина, внутривенно 40% раствор глюкозы.

- Rp. Sol. Nitroglycerin! 1% 5,0  
L7S. 2—3 капли на прием при Солях в с<рдце (на сахаре сосать)
- Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. 1 мл под кожу
- Rp. Sol. Glucosi 40% 50,0 Sterilise tur! DS. По 20 мл 1—2 раза в день внутривенно

Если нитроглицерин не снимает болей, необходимо подкожное впрыскивание морфппа или омнонона.



- Пр. Sol. Morphni hydrochloric i i% 1,0 1). t. d. N. 6 in amp. MDS. 1 мл под кожу при болях

Rp. Sol. Omnoponi 2% 1,0 P. t. d. N. 6 in amp. MDS. 1 мл под кожу при болях

При наступлении сердечной недостаточности вместе с морфином или омнопоном впрыскивают камфору.

При сердечной недостаточности, особенно резком падении артериального давления (коллапсе)— подкожные впрыскивания кофеина и внутривенное введение строфанта (строфантина) вместе с глюкозой.

Rp. Sol. Coffeini natric-brnzoici 20% 1,0 D. t. d. N. 10 in amp. S. No 1 мл под кожу 3—4 раза в день

Rp. Sol. Strophanti^ 0,1% 0,25 Sol. Glucosi 40% 20,0 Sterilisetur! DS. Для внутривенного введения. Вливать медленно

Впоследствии рекомендуется такой же режим, как у больных с артериокардиосклерозом и хронической сердечно-сосудистой недостаточностью.

КАМНИ ПОЧЕК см. *Почечнокаменная болезнь*.

КАРДИОСКЛЕРОЗ, МИОКАРДИОСКЛЕРОЗ, МИОКАРДИОЦИРРОЗ (CARDIOSCLEROSIS, MYOCARDIOSCLEROSIS, MYOCARDIOCIRRHOSIS). При этом заболевании происходит образование соединительной рубцовой ткани в сердечной мышце. При миокардитах в мышечной ткани сердца развивается воспалительный процесс с последующим перерождением и некрозом мышечных волокон. При нарушениях питания сердечной мышцы (миокардио-дистрофия, склероз коронарных сосудов) происходит постепенно перерождение и атрофия мышечных волокон. В том и другом случае на месте погибшей мышечной ткани разрастается соединительная ткань, вследствие чего понижается работоспособность миокарда.

Симптомы и течение. Вначале больной может чувствовать себя совершенно здоровым, трудоспособность не нарушается. Объективно отмечается увеличение сердца и приглушенные тоны. При прогрессировании болезни наступает сердечная недостаточность (см. *Сердечная недостаточность хроническая*). При недостаточности преимущественно левого желудочка могут появиться приступы сердечной астмы.

Распознавание. Нужно иметь в виду пороки сердца и миокардиты.

Лечение. В стадии компенсации — установление правильного режима (см. *Порок сердца компенсированный. Атеросклероз*). При декомпенсации — см. *Сердечная недостаточность хроническая, Лечение*.

КАТАР ЖЕЛУДКА см. *Гастрит хронический*.

КАТАРРАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ см. *Пневмония очаговая*.

КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ см. *Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки*, гл. II *Инфекционные болезни*, *В брюшном тифе*, *Дизентерия*, гл. VI *Хирургические болезни*.

КОЛИТ ОСТРЫЙ. ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОЛСТЫХ КИШОК (COLITIS ACUTA). Причины острого колита те же, что и острого гастрита (см. *Гастрит острый, гастроэнтероколит острый*).

Симптомы и течение. Основной признак — понос. Испражнения очень часты, жидкие, слизь выделяется вместе с испражнениями, не успев смешаться с ними. Обычно с каждой дефекацией выделяется сначала небольшое количество кала, а затем одна слизь, часто с примесью гноя и крови. При острых колитах наблюдается гнилостная диспепсия — испражнения с резким гнилостным, тухлым запахом. Боли обычно по всему животу, часто схваткообразны; (кишечная колика), особенно перед позывом на стул. При поражении нижнего отрезка, особенно сигмовидной или прямой кишки болезненные тенезмы (позывы на низ). Резкая боль отмечается также при значительном метеоризме, при раздражении брюшины. При инфекционных колитах часто наблюдается повышение температуры (иногда до 39—40°) и явления общей интоксикации: головная боль, общая слабость, потеря аппетита, обложенный язык, помраченное сознание, судороги (при значительном обезвоживании организма). Острый колит при правильном лечении и уходе прекращается большей частью и 1—2 недели: иногда он переходит в хронический. Острый колит, наблюдающийся при *дизентерии* (см.) и *холере* (см.), имеет своеобразные симптомы и течение.

Распознавание. Часто острый колит комбинируется с острым энтеритом (воспаление тонких кишок — энтероколит) или острым гастритом (гастроэнтероколит). В первую очередь нужно установить, не является ли острый колит дизентерийного происхождения или иного (например, брюшного тифа). Изолированный острый колит нужно дифференцировать с острым гастритом и энтеритом, а также с хроническим колитом.

Лечение. При сильных поносах, особенно с сильными болями и высокой температурой, необходим постельный режим. Лечение следует начинать дачей слабительного (касторовое масло, слабительные соли). Затем применять сульфаниламидные препараты (схема приема препаратов см. *Крупозное воспаление, легких*). Кроме указанных выше сульфаниламидных препаратов, при острых, кишечных заболеваниях предпочитают давать препараты, которые плохо всасываются из кишечника: дисульфид и менее токсичные — сульфгин и фталазол.

Rp. DisuUani 1,0 D. t. d. N. 12 S. По I порошку 3—4 раза в день

Rp. Sulgini 1,0 D. t. d. N. 12 S. По I порошку через 4 часа

Rp. Phtalazoli 1,0 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку через 4 часа

Сульфип и фталазол дают по обычной схеме сульфаниламидных препаратов.

При уменьшении острых кишечных явлений дозировку сульфаниламидных препаратов можно уменьшить (до 0,5 на прием). Каждый порошок сульфаниламидных препаратов нужно обязательно запивать большим количеством жидкости, лучше всего щелочной (полстакана боржома или содового раствора — 1 чайная ложка соды на полстакана воды).

Применяется также бактериофаг, противодизентерийный или противоколитный (против кишечной палочки), по 20 мл два раза в день натощак 2 дня подряд. Первый раз дают в 1—2 часа ночи, а второй — в 6—7 часов утра; каждый раз запивают 5% раствором соды (полстакана). При приеме бактериофага нельзя давать слабительные средства. На живот — грелки или согревающий компресс; обильное питье, лучше в горячем виде. При обезвоживании организма — подкожные вливания физиологического или рингеров-ского раствора, или 5% раствор глюкозы (см. *Гастрит острый*).

Первые 2 дня дается только жидкая пища: горячий чай с сахаром и лимоном или красным вином, слизистые супы; молоко из пищи исключается. В первые же дни болезни (при явлениях гнилостной диспепсии) можно назначить на 1—2 дня яблочную диету (без всякой другой пищи и питья): 5—6 раз в день по 250 г протертых спелых яблок (лучше всего антоновских), очищенных и без сердцевин. Затем — мясные бульоны, белые сухари, кисели (черпичный, клюквенный и др.), желе, хорошо протертые каши (рисовая, манная и др.), приготовленные на воде. Когда пройдут острые явления, разрешают вареные протертые овощи, рубленое вареное мясо (фрикадели, паровые котлеты). Постепенно переходят на общий стол.

Внутрь болеутоляющие или антиспастические »редства (атропин, белладонна, папаверин), дезинфицирующие (салол, бензонафтол), вяжущие (таннальбип, висмут).'

Rp. Extr. -Belladonnae 0,015 Bismuti subnitrici Tannalbini aa 0,5 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Bismuti subnitrici Saloli aa 0,5 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в деда.

Rp. Benzonaphtholi Saloli aa 0,5 M. f. pulv.- D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в д- пь

При похолодании рук и ног ставят грелки.

При ослаблении сердечной деятельности — под кожу кофеин, камфору.

**КОЛИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (COLITIS CHRONICA).** Причины часто те же, что и при хроническом гастрите (см.): злоупотребление слабительными и клизмами, особенно холодными; острый колит, если — пс устранена вызвавшая его причина или недостаточно леченный; запоры, при которых остатки пищи под действием бактерий толстого кишечника, разлагаясь, раздражают стенку кишок и вызывают воспаление.

**Симптомы - , и т е ч е н и е.** Хронические колиты обычно сопровождаются запорами, иногда поносами; часто хроническо запоры сменяются на несколько дней поносами с выделением большого количества слизи. При гнилостных процессах испражнения имеют тухлый запах. При преобладании брожения образующиеся газы, раздувая кишки, пучат живот, подпирают диафрагму п вызывают у стариков, а также у сердечных больных одышку и боли в сердце; больные часто чувствуют тяжесть в животе и умеренные боли, иногда схваткообразные; при пальпации прощупываются болезненные кишки.

При поражении сигмовидной или прямой кпшки часты позывы и тенезмы. Продукты гниения всасываются из кишок в кровь и отравляют весь организм; жалобы на плохой аппетит, дурной вкус во рту, головные боли; развивается общая слабость и малокровие, плохое настроение. Болезнь может длиться годами.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Хронический колит надо отличать от хронического энтерита.

**Л с ч е н и е.** Лечение приходится индивидуализировать в зависимости от наличия симптомов. Необходимо соблюдение правильного пищевого режима, борьба с запорами и поносами (см.). При поносах и метеоризме нельзя давать грубую и молочную пищу. Овощи и фрукты (компоты) дают в протертом виде, вместо черного — белый хлеб. При гнилостных процессах избегать мяса и яиц, при бродильных — углеводов (см. *Поносы*). При поражении нижних отрезков кишечника периодически ставят очистительные клизмы (при запорах) из горячей или теплой воды, к которой можно добавлять марганцовокислый калий. Хорошее действие, особенно при метеоризме, оказывают ромашковые клизмы (1 столовую ложку на заварку).

Полученный, отвар процедить через марлю, отжать и влить в кружку с теплой или горячей водой (от 2 до 5 стаканов). При значительном метеоризме дают карболен (по 0,5 два раза и день) или белую глину (Bolus alba) (по 1 порошку 3—4 раза в день).

При болях — диатермия, кварцевое облучение, а также белладонна с дезинфицирующими средствами.

Rp. Extr. Belladonnae 0,015 Saloli 0,5 M. f. pulv. D. t, d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Exlr. Belladonnae 0,015  
Benzonaphtholi 0,5 M. f. pulv. D. t. d.  
N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

КОЛЛАПС см. *Сердечно-сосудистая недостаточность острая*.  
КОМА ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ см. *Диабет сахарный*. КОМА  
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ см. *Диабет сахарный*. КОМА УРЕМИЧЕСКАЯ  
см. *Уремия*. Нефрит хронический. Нефроз нр. и осклер оз.  
КОРОНАРОСКЛЕРОЗ см. *Кардиосклероз*. Стенокардия.  
КОРОНАРОТРОМБОЗ см. *Инфаркт миокарда*. КРЕТИНИЗМ см. *Зоб  
эндемический*. КРОВАВАЯ РВОТА см. *Кровотечение желудочное*.  
КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ПОЛОСТЬ ПЛЕВРЫ. ГЕМОТОРАКС  
(НАЕМОТНОКАХ). Главные причины: травмы и ранения грудной  
клетки.

Симптомы и течение. Жидкость в полости плевры (см.  
*Гидроторакс*); острое малокровие при внутреннем кровотечении (см.  
*Кровотечение легочное*).

Лечение см. *Кровотечение легочное*. При сильной одышке и  
сердечной декомпенсации удаление крови из полости плевры малыми  
порциями (30—50—100 мл), сердечные средства. В случае наступления  
острого малокровия—переливание крови и дальнейшее лечение анемии  
(см.).

КРОВОТЕЧЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЕ (НАЕМАТЕМЕСИС). Наблю-  
дается чаще всего при язве желудка, раке (вследствие распада  
раковой опухоли), при венозном застое в стенках желудка (на  
пример, циррозе печени), при повышенной кровоточивости (гемо-  
филии, тромбопении). Значительное кровотечение обычно сопро-  
вождается рвотой (кровавая рвота) или дегтеобразным стулом  
(см. *Язвенная болезнь*); небольшие кровотечения могут протекать  
незаметно, так как кровь поступает из желудка в кишечник, где  
подвергается перевариванию.\*

Симптомы и течение см. *Язвенная болезнь же-гуд-ка и  
двенадцатиперстной кишки*.

Лечение см. *Язвенная болезнь желудка*. КРОВОТЕЧЕНИЕ  
КИШЕЧНОЕ см. *Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной  
кишки*, гл. П. *Инфекционные болезни*, *Брюшной тиф*, *Дизентерия*, гл.  
VI. *Хирургические болезни*.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОЕ. КРОВОХАРКАНИЕ (НАЕМО-  
РТОЕ). Причины: часто легочный туберкулез, а затем другие легочные  
заболевания (бронхоэктазия, абсцесс, рак, инфаркт, травма и ранение  
легкого, пневмосклероз); застои в легких (отек легких, порок сердца,  
особенно стеноз митрального отверстия); гипертония (атеросклероз) и  
кровооточивость.

Симптомы и течение. С кашлем выделяется мокрота,  
окрашенная кровью, или отдельные кровяные плевки (кровохаркание),  
или более значительное количество крови (легочное кровотечение), от  
которого иногда больные погибают. При сильном кровотечении  
наступает острое малокровие и коллапс (резкий упа-

док сердечно-сосудистой деятельности): резкая бледность покровов и  
слизистых, общая слабость, головокружение, обморок, похолодание  
конечностей, холодный пот, малый и частый (нитевидный) пульс, а  
иногда даже полное его исчезновение.

Лечение. Полный покой, приподнятое положение в постели.  
Запрещение разговоров, курения; ограниченная ода и особенно питье;  
все — в холодном виде. Очищают кишечник; иногда по грудную клетку  
кладут пузырь со льдом, а к ногам — грелки. При оказании первой  
помощи дают 1—2 чайных ложки поваренной соли в Va стакана воды.

Внутривенные вливания поваренной соли (гипертонический рас-  
твор). Внутрь или внутривенно — хлористый кальций, глюкоза.

Rp. Sol. Natrii chlorati 10% 20,0  
Sterilisetur!  
DS. Для внутривенного вливания по  
10.мл 1—2 раза в день

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 20.0  
Sterilisetur!  
DS. Для внутривенного вливания по 10  
мл 1—2 раза в день

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 200,0  
DS. По 1 столовой ложке 4 раза в день

При сильном кровотечении вводится 50'—100 мл нормальной  
лошадиной сыворотки подкожно. Внутрь дают витамин К,

Rp. Vicasoli 0,015  
D. t. d. N. 6 in tab.  
S. По 1 таблетке 3 раза в день

При сильном кашле — наркотические (кодеин, дионин, а иногда  
морфин). При кровотечении, вызванном застойными явлениями в  
легких,—сердечные средства (камфора, наперстянка и др.).

Rp. Sol. Dionini 2% 15,0  
DS. По 15 капель 3 раза в день

Rp. Sol. Morphini- h'drochlorici 1% 1,0 P, t.  
d: N. 6 in amp. S. Но 1 мл под кожу

Rp. Inf. fol. Digitalis ex 0,6:200,0  
DS. По 1 столовой ложке через 3 часа

КРОВОХАРКАНИЕ см. *Кровотечение легочное*. КРУПОЗНАЯ  
ПНЕВМОНИЯ см. *Пневмония крупозная* Г ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ. Под  
легочным сердцем понимают синдром (совокупность симптомов)  
сердечного заболевания, вызванного темп или иными болезненными  
изменениями в легких.

При легочной эмфиземе, пневмосклерозе, бронхиальной астме, бронхоэктазах, туберкулезе легких (см.) и других легочных заболеваниях затруднено продвижение крови в малом кругу кровообращения (в легких). Для преодоления этого препятствия правому желудочку приходится усиленно работать, что приводит к гипертрофии правого желудочка.

**Симптомы и течение.** Пока сердечная мышца справляется с работой, компенсирует легочную недостаточность, наблюдаются симптомы указанных выше легочных заболеваний. Объективно отмечается при перкуссии увеличение сердца вправо, приглушенность сердечных тонов. При наступлении правожелудочковой сердечной недостаточности наблюдаются явления застоя преимущественно в большом кругу кровообращения: усиливается одышка (уже бывшая при легочной недостаточности), появляется цианоз, увеличение печени, отеки, асцит (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая*). Течение болезни зависит от степени легочных изменений и сердечной недостаточности.

**Распознавание.** Наличие увеличения границы сердца вправо, сердечная недостаточность правожелудочкового типа с одновременным хроническим заболеванием легких указывают на развитие симптомов легочного сердца.

**Лечение** основного легочного заболевания и сердечной недостаточности (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая*).

**ЛЕЙКЕМИЯ (ЛЕЙКОЗ), БЕЛОКРОВИЕ (LEUKAEMIA).** Лейкемией (лейкозом), или лейкопрогием, называется заболевание, когда в кровеносных органах, часто и в других тканях, значительно разрастается лейкобластическая (образующая белые кровяные тельца), ткань, а в крови до громадных размеров увеличивается число белых кровяных телец, причем по своему строению они отличаются от нормальных лейкоцитов периферической крови. Нормально в 1 мм<sup>3</sup> крови находится 6 000—8 000 белых кровяных телец. При лейкопрогии число лейкоцитов доходит до 200 000—500 000 и более в 1 мм<sup>3</sup>.

Причина этой болезни еще не установлена. Внешние раздражения имеют значение в развитии лейкопрогий. Раздражение кожи рентгеновыми лучами, хронические отравления бензолом и мышьяком могут способствовать возникновению болезни. По своему происхождению, быстрому разрастанию лейкобластической ткани, течению и исходу болезни хронические лейкозы сходны со злокачественными опухолями.

Различают хроническую миелоидную лейкопрогию, когда в крови встречаются патологические формы гранулоцитов (миелобласты и миелоциты), хроническую лимфатическую, когда в крови обнаруживаются лимфоциты, из которых в норме образуются лимфоциты-иоциты лейкопрогии.

**Симптомы и течение болезни.** При миелоидной лейкопрогии, кроме большого количества в крови миелобластов и миелоцитов, одним из главных признаков является огромная селезенка, занимающая иногда всю левую и частично правую половину живота. При лимфатической лейкопрогии селезенка не такая большая, но зато

значительно увеличиваются лимфатические узлы: шейные, паховые, подмышечные и др. Лейкемия часто сопровождается малокровием, которое прогрессирует вместе с основной болезнью.

Больные испытывают общую слабость, головокружение и одышку. Часто наблюдаются боли в костях, особенно в грудинах. Болезнь обычно протекает хронически, в течение нескольких лет, постепенно ухудшаясь.

Острая форма лейкопрогии сопровождается высокой температурой септического характера.

Больные жалуются на слабость, одышку, головную боль и боль в рту. У больных\* быстро развивается резкая анемия, появляются кровоизлияния на коже и слизистых оболочках. В полости рта и зева часто развиваются язвенные и некротические процессы.

Больные погибают в течение нескольких недель, иногда 2—3 месяцев.

**Распознавание** хронических форм по основанию увеличенной селезенки и лимфатических желез, картины крови, рецидивов болезни и постепенно прогрессирующего течения.

Острая лейкопрогия диагностируется на основе указанных выше симптомов — быстрого прогрессирования болезни и главным образом по картине крови.

**Лечение.** Лучшим средством является облучение рентгеновыми лучами селезенки, лимфатических узлов, костей (костного мозга).

В последние годы стали применять лечение радиоактивным фосфором и эмбином.

При малокровии хорошее действие оказывает мышьяк и железо.

Rp. Sol. arsenicalis Fowleri 10,0 Aquae Menthae 15,0 .

MDS. По 8—15 капель после еды 3 раза в день

Курс лечения — 1—1½, месяца.

Rp. Ferri reducti 0,5

D. t. d. N. 15 in oblatiis

S. По 1 облатке 3 раза в день

При значительной анемии — переливания крови по 150—250 мл.

Лечение острой лейкопрогии производится в основном пенициллином (см. *Абсцесс легкого*) и переливанием крови (эритроцитарной массы). Тщательный уход, уход за ртом, полноценное питание, витамины, симптоматическое лечение.

**ЛЕЙКЕМИЯ ОСТРАЯ (ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ)** см. *Лейкемия*.

**ЛЕЙКОПЕНИЯ.** Лейкопенией называется уменьшение в крови лейкоцитов, когда их количество уменьшается ниже 5 000 в 1 мм<sup>3</sup>. Лейкопения характерна для вирусных инфекций: гриппа, болезни Боткина, кори, а также для некоторых других инфекций — брюшного тифа, паратифов, малярии. Кроме того, лейкопения возникает от интоксикации различными ядами, в том числе и лекарственными веществами. Лечение рентгеновыми лучами тоже может вызвать лейкопению (см. *Агранулоцитоз. Анемия апластическая*).

**ЛЕЙКОЦИТОЗ.** Увеличение числа лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. При лейкоцитозе в отличие от лейкоемии увеличение числа лейкоцитов происходит за счет нормальных элементов крови. В норме в  $1 \text{ мм}^3$  6 000—8 000 лейкоцитов. При многих инфекционных заболеваниях количество лейкоцитов увеличивается. Лейкоцитоз является реакцией организма на внедрившуюся инфекцию. В изменениях количества лейкоцитов большое значение имеет регуляция центральной нервной системы.

Лейкоцитоз наблюдается при крупозном воспалении легких, различных септических заболеваниях, сыпном и возвратном тифе, скарлатине, дифтерии и др. Иногда количество лейкоцитов увеличивается в несколько раз, например, при крупозной пневмонии доходит до 20 000—30 000 и более в  $1 \text{ мм}^3$ . Иногда наблюдается так называемый физиологический лейкоцитоз через 1—2 часа после принятия пищи, после физического напряжения. У беременных и новорожденных также отмечается увеличение количества белых кровяных телец. При лейкоцитозе обычно наблюдается не равномерное увеличение всех видов лейкоцитов, а увеличение только одного или 2—3 видов; количество же других видов лейкоцитов может даже уменьшаться (см. *Лейкоцитарная формула*, гл. XV. *Простейшие лабораторные исследования*).

**ЛИМФАТИЧЕСКАЯ ЛЕЙКЕМИЯ** см. *Лейкемия*.

**ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ.** Это злокачественное заболевание лимфатических узлов и селезенки. Причина этой болезни, также как злокачественных опухолей и лейкоемий, неизвестна.

**СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ.** ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЮТСЯ увеличенные лимфатические узлы. Сначала увеличиваются шейные узлы, а затем подмышечные, паховые, средостения, брыжеечные и т. д. Лимфатические узлы плотны, безболезненны, подвижны, не спаяны с окружающей тканью. Селезенка увеличена. Характерна волнообразная лихорадка. Больные жалуются на общую слабость и кожный зуд. Постепенно нарастает анемия. Болезнь длится обычно 2—3 года, реже более длительный срок.\*

**Распознавание.** Следует отличать главным образом от туберкулезного лимфаденита, туляремии, лимфатической лейкоемии и злокачественных опухолей (лимфосаркоматоз). При туберкулезе обычно не такое множественное поражение лимфатических узлов, узлы часто спаяны, дают гнойный распад со свищами; селезенка не увеличена. При лимфатической лейкоемии характерна картина крови, нет типичной для лимфогранулематоза лихорадки и кожного зуда.

При лимфосаркоматозе железы спаяны, разрастаются в определенном месте. Селезенка не увеличена, лихорадка бывает редко.

**Лечение.** Главный метод лечения — рентгенотерапия. В настоящее время стали применять новое средство — эмбохин. Симптоматическое лечение: пиридон, аспирин, мышьяк, железо и др.

**ЛИПОИДНЫЙ НЕФРОЗ** см. *Нефроз липоидный*.

**ЛЮМБАГО** см. *Миозиты и миалгии*.

**ЛЯМБЛИОЗ** см. *Холецистит; Энтерит хронический*.

**МАЛОКРОВИЕ** см. *Анемия*.

**МАЛОКРОВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ** см. *Анемия злокачественная*.

**МЕЗАОРТИТ** см. *Аортит*.

**МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ** см. *Аритмии*. - JJ- „ „ „

**МЕТЕОРИЗМ. ВЗДУТИЕ ЖИВОТА ГАЗАМИ (METEORISMUS).**

Метеоризм — симптом, который наблюдается главным образом при различных кишечных заболеваниях. Причины: повышенное образование газов при кишечном брожении или гниении при употреблении в пищу большого количества углеводов, особенно растительной клетчатки; задержка газов в кишечнике вследствие пониженного их всасывания; заглатывание воздуха у страдающих невротами; сужение кишок или полная непроходимость их; застои крови в полости живота при сердечной недостаточности. Резкий метеоризм наблюдается при общем перитоните (паралич гладкой мускулатуры кишечника).

**Симптомы.** Жалобы на чувство тяжести и распирающий живот, схваткообразные боли, проходящие после отхождения газов. Живот вздут, при перкуссии — тимпанический звук.

**Лечение.** При непроходимости кишечника и перитоните — хирургическое лечение. При застойных явлениях — лечение основного заболевания. При усиленном брожении — диетическое. Эзита: ограничение потребления углеводистой и богатой клетчаткой пищи; преимущественно белковая пища: бульоны, рыбные супы (уха), мясо, рыба, яйца, творог, сметана. Внутрь карболом (по 0,5 два раза в день), белая глина, атропин, белладонна, папаверин, ветрогонный чай.

Rp. *Boli albae* 1,0 D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Rp. *Sol. Atropini sulfurici* 0,1% 10,0 DS. По 8 капель 3 раза в день

Rp. *Extr. Belladonnae* 0,015  
*Papaverini hydrochlorici* 0,02  
*Sacchari albi* 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12  
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. *Rad. Valerianae* 10,0  
*Fol. Menthae*  
f met. *Carvi* „ „ „ „  
*Flor. Chamomillae* aa 20,0 *Fruct.*  
*Foeniculi* 30,0

MDS. По 2 чайных ложки на стакан кипятка, заварить, процедить и пить по стакану 2 раза в день

При запорах — легкие слабительные: вазелиновое масло, ревень, фенолфталеин, лакричный порошок (см. *Запоры*). Слабительные иногда чередуют с клизмами; хорошо ставить клизмы с ромашкой. Массаж живота, диатермия. При значительном метеоризме — газоотводная трубка.

**МИАЛГИИ** см. *Миозиты и миалгии*.

**МИКСЕДЕМА (МУХОЕДЕМА), ГИПОТИРЕОЗЫ (HYPOTHYREOSIS).** Микседема образуется в результате недостаточной функции щитовидной железы, уменьшения (гипотиреоз) или полного отсутствия ее гормонов. Могут появиться явления микседемы после удаления щитовидной железы и даже неполного ее удаления. Иногда она появляется в период угасания функции половых желез у женщин. Гипотиреоз наблюдается часто при эндемическом зобе. Острые инфекционные болезни, авитаминозы, голодание также ведут к гипотиреозам и микседеме.

**Симптомы и течение.** Основным симптом — появление своеобразных отеков на лице, шее, конечностях, иногда и на всем теле. Кожа плотна, суха, шелушится; при надавливании кожи пальцем ямка не образуется. Потоотделение понижается или совсем прекращается. Характерно бледное одутловатое лицо с тупым выражением. Температура тела понижена; больные зябки, постоянно жалуются на ощущение холода; волосы сухие, часто выпадают; ногти ломкие. Понижаются все функции: обмен веществ снижен, пульс редкий, сердечные сокращения вялые. Упорные запоры, вялость движений, апатичность, плохое реагирование на различные возбуждения. Микседема — болезнь хроническая, тянется годами.

**Лечение.** Длительные приемы тиреоидина, под влиянием которых болезненные явления заметно уменьшаются, а иногда и совсем исчезают.

Rp. Thyreoidini ОД  
D. t. d. N. £0 in tab.  
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

При появлении сердцебиения, потливости, дрожания, резкого похудания, поносов следует временно прекратить дачу тиреоидина или уменьшить дозу.

**МИОЗИТЫ (MYOSITIS) — ВОСПАЛЕНИЕ МЫШЦ, МИАЛГИИ (MYALGIA)** — боль в мышцах без воспалительных явлений. Вызываются инфекцией или интоксикацией. Большую роль играет охлаждение. Обыкновенно поражаются отдельные группы мышц: шейные, плечевой пояса, поясничные и т. д.

**Симптомы и течение.** Мышцы набухают, становятся болезненными при давлении; иногда совершенно невозможно движение вследствие сильной боли. При поражении шейных мышц (**torticollis**) голова больного согнута набок и он не может ее поворачивать. При поражении поясничных мышц, **п р о с т р е л е (lumbago)** движения в поясничной части позвоночника ограничены. Острое мышечное воспаление большей частью в несколько дней проходит бесследно. Лица, перенесшие миозит, предрасположены к рецидивам этой болезни.

При хронических воспалениях отдельных мышечных групп отмечаются постоянные мышечные боли в пояснице, руках или ногах. Боли иногда уменьшаются, совсем проходят или же вновь обостряются. Хронический миозит может тянуться годами.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Надо отличать от ревматизма, невралгий, спондилита, гинекологических заболеваний (при болях в пояснице).

**Лечение.** В остром периоде — большие дозы салициловых препаратов внутрь; различные растирания раздражающими и болеутоляющими средствами.

Rp. Natrii salicylici 1,0 D. t. d. N. 12 S.  
По 1 порошку 6 раз в день  
Rp. Pyra-midoni 0,3 D. t. d. N. 12 S. По  
1 порошку 4 раза в день  
Rp. Methylli salicylici 10,0 Chloroformii . 01. Hyoscyami aa  
15,0 MDS. Растирание. Перед употреблением  
взбалтывать  
Pr. 01. Terebinthinae Chloroformii aa 10,0 01. Hyoscyami 30,0  
MDS. Растирание. Перед употреблением взбалтывать

Согревающие компрессы пліг горчичники, грязевые лепешки, парафин на больные мышцы. Физические методы лечения: теплые или горячие ванны, светолечение, массаж и др. Кроме того, в хронических случаях — лечение на курортах: соленные, серные или грязевые ванны. При хроническом миозите остерегаться охлаждения.

**МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ (MYOCARDIODYSTROPHY).** При расстройстве питания сердечной мышцы (миокардиодистрофии) в ней происходят различные химические изменения, нарушения обмена веществ. Все трофические изменения в миокарде и нарушения обмена регулируются центральной нервной системой через трофические периферические нервные волокна. Причины миокардиодистрофии: общее малокровие, переутомление сердца («усталое», «спортивное») и, наоборот, нетренированность сердца у лиц, долгое время находящихся в постели или ведущих сидячий образ жизни, общее ожирение, различные интоксикации (алкоголь, никотин, хлороформ), авитаминозы, заболевания эндокринных желез (микседема, гипертиреоз), усиленная работа сердечной мышцы (при пороках сердца, гипертонии, эмфиземе легких) и др.

В начальной стадии болезни наблюдается только функциональное ослабление сердечной мышцы без патологоанатомических изменений. Затем в сердечной мышце развиваются различные дистрофические изменения (белковая и жировая дистрофия), которые впоследствии могут привести к разрастанию соединительной ткани в сердечной мышце (кардиосклероз).

**Симптомы и течение.** Симптомы бшгееая и ее течение зависят от основного заболевания. Явления сердечно-сосудистой недостаточности: одышка, появляющаяся при незначительных физических напряжениях (ускоренная ходьба, подъезы пи лестнице

«

и пр.), умеренно расширенное сердце, приглушенные тоны, пульс уменьшенного наполнения и напряжения, иногда систолический шум на верхушке сердца, на ногах небольшие отеки.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Определить основное заболевание, назвавшее изменения со стороны сердца. Наибольшие трудности представляет вопрос, имеются ли только дистрофические изменения в миокарде или уже в нем развивается склеротический процесс. Лечение следует проводить против основного заболевания и против сердечной недостаточности (см. *Сердечно-сосудистая Недостаточность*). При ожирении и недостаточной подвижности больного — тренировка сердца физкультурой; при усталом и перенапряженном сердце — постепенная тренировка после определенного отдыха. При функциональных и небольших анатомических изменениях в сердечной мышце направлять в санатории или на курорты (Кисловодск, Мацеста и др.).

**МИОКАРДИОПАТИЯ (MYOCARDIOPATHIA).** Общее понятие для любой болезни сердечной мышцы: миокардита, миокардиодистрофии, кардиосклероза.

**МИОКАРДИОСКЛЕРОЗ** см. *Кардиосклероз*.

**МИОКАРДИОЦИТРОЗ** см. *Кардиосклероз*.

**МИОКАРДИТ ОСТРЫЙ. ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ (MYOCARDITIS ACUTA).** Причины: различные острые инфекционные заболевания: чаще острый ревматизм и дифтерия, крупозная пневмония, брюшной и сыпной тиф, скарлатина, ангина, грипп и другие инфекции. Воспаление в сердечной мышце большей частью сопровождается дистрофическими и некротическими процессами с последующим разрастанием соединительной ткани, что приводит к кардиосклерозу.

**С и м п т о м ы т е ч е н и я.** Жалобы на неприятные ощущения боли в области сердца, сердцебиение, общую слабость. Сердце расширено, тоны глухие (ослабление сердечной мышцы). Пульс учащен, плохого наполнения. Часто появляются симптомы сердечной недостаточности: одышка, цианоз, а иногда и отеки. Обычно наблюдается повышенная температура. Восстановление функции сердечной мышцы происходит медленно. Иногда сердце навсегда остается неполноценным (вследствие склеротических изменений в сердечной мышце).

**Р а с п о з н а в а н и е.** Отличать острый миокардит от других заболеваний сердечной мышцы, главным образом от миокардиодистрофии (на основании наличия острой инфекционной болезни, повышенной температуры и вышеуказанных симптомов).

**Л с ч е н и е.** Продолжительный полный покой в постели, абсолютное запрещение вставать (все естественные отправления производятся в постели). Обязательный покой для нервной системы. Забота о сне больного: при нервном возбуждении — успокаивающие средства (бромиды, валериана), при бессоннице — снотворные (люминал). При значительной тахикардии — пузырь со льдом на область сердца, при похолодании конечностей — грелки к ногам, ограничение питья, легкая пища в протертом виде, частые ее приемы (каждые 2—3 часа) и небольшими порциями. Следить за исправным действием кишечника и количеством выделяемой мочи.

Внутрь кофеин, стрихнин с валерианой или ландышевыми каплями. В остром периоде не рекомендуется применение сильнодействующих сердечных средств.

Rp. T-rae Strychni 5,0  
T-rae Valerianae simplicis 15,0 MDS. По  
20 капель 3 раза в день

Rp. T-rae Valerianae simplicis  
T-rae Convallariae majalis aa 10,0 MDS.  
По 20 капель 3 раза в день

При значительной тахикардии — наперстянка - в небольших дозах, иногда в сочетании с хиной, а также бромистые препараты.

Rp. Pulv. folii Digitalis 0,05 Chinini  
hydrochlorici 0,1 M. f. pulv. D. t. d. JJ. 6  
S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Pulv. folii Digitalis 0,05  
Camphorae monobromatae 0,15  
M. f. pulv. D. t. d. N. 6  
S. По 1 порошку 3 раза в день

При развитии сердечной недостаточности — то же лечение как при сердечно-сосудистой недостаточности острой и хронической (см.).

**МИОКАРДИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (MYOCARDITIS CHRONICA).**

Причины: острый миокардит, часто рецидивирующий острый ревматизм, хронические инфекционные болезни (туберкулез и сифилис). При хронических миокардитах в мышце постепенно развиваются склеротические изменения.

**С и м п т о м ы , т е ч е н и е и л е ч е н и е** см. *Миокардит острый, Миокардиодистрофия, Кардиосклероз, Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая*.

**МИЭЛОИДНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ** см. *Лейкемия*.

**МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ** возникает на судне при морской качке. Качание судна происходит в трех направлениях: по поперечной оси (килевая качка), по продольной оси (боковая качка), вверх и вниз (опускание и поднятие судна). Наиболее тяжело переносится смешанная качка. У лиц предрасположенных явления морской болезни могут появляться при качке самолета, при продолжительной езде на автомобиле, поезде, даже трамвае. В возникновении морской болезни большую роль играет раздражение коры головного мозга. У некоторых лиц морская болезнь возникает только от страха, что они обязательно заболеют, если будет качка.

В развитии морской болезни большое значение имеет состояние вестибулярного аппарата; глухие морской болезнью не болеют. Повышенная возбудимость блуждающего нерва предрасполагает к морской болезни.

**С и м п т о м ы и т о ч е н и е.** Начинается болезнь с появления головокружения, затем наступает тошнота и рвота, сначала съе-

денной пищей, потом со слюною и желчью. Вид шгщи, различные запахи, в том числе запах пищи, способствуют возникновению рвотных движений. Лицо бледное, холодный пот, пульс редкий, головная боль, отсутствие аппетита, значительная слабость, сонливость, угнетенное состояние. Все болезненные явления быстро проходят при высадке на берег или прекращении качки.

**Профилактика и лечение.** Находиться на палубе, лучше в средней части судна, вдали от кухни и машинного отделения. Не вести разговоров о морской болезни, заниматься чем-либо отвлекающим от мыслей о качке, временами лежать с закрытыми глазами, чтобы не видеть качающиеся предметы.

Приять 1-2 таблетки азрона (Hyoscyami camphorati 0,0001; Scopolamini hydrochloric] 0,0004).

Rp. Aeroni 0,0005

D. t. d. N. 10 in tab.

DS. Принять 1—2 таблетки при появлении головокружения или тошноты

После рвоты глотать мелкие кусочки льда, томатный или фруктовый сок в холодном виде, крепкий чай или кофе. Пищу принимать небольшими порциями, сухую и холодную.

Внутрь дают препараты атропина, бромиды и спотворные.

При неукротимой рвоте — морфин под кожу.

**НЕВРОЗЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ.** Неврозами называются заболевания, вызываемые расстройством высшей нервной деятельности. Эти расстройства выражаются в нарушении взаимодействия между возбуждательными и тормозными процессами в коре головного мозга. Может наблюдаться чрезмерная патологическая устойчивость возбуждательных процессов и слабость тормозных, а также, Наоборот, стойкость тормозных и слабость возбуждательных.

Вследствие тесной взаимосвязи внутренних органов с корой головного мозга различные нарушения высшей нервной деятельности вызывают те или иные функциональные изменения и во внутренних органах. Неврозами внутренних органов (сердечно-сосудистые, желудочные, кишечные и др.) называются заболевания с резкими функциональными нарушениями этих органов, вызванные расстройством высшей нервной деятельности.

**НЕВРОЗ ЖЕЛУДКА.** Различные тяжелые переживания, отрицательные эмоции вызывают функциональные нарушения высшей нервной деятельности которые подавляют и изменяют пищеварительные функции желудка. Все это впоследствии может привести к морфологическим изменениям слизистой оболочки. Секреторные и двигательные функции желудка осуществляются главным образом блуждающим нервом, регулируемым нейтральной нервной системой. При волнении, тяжелых переживаниях может совершенно пропасть аппетит. Часто нервные воздействия могут привести к полной ахилии. Например, мысль о раке может совершенно лишить человека аппетита, вызвать упорную рвоту и т. д. Неврозы желудка наблюдаются у людей с повышенной нервной возбудимостью и неустойчивой вегетативной нервной системой (см. *Неврозы внутренних органов*).

**Симптомы и течение.** Разнообразные и многочисленные жалобы больных, не соответствующие объективным данным: отсутствие аппетита или «волчий голод» (буллимия), отрыжка, изжога, иногда рвота, неприятные ощущения и тяжесть в подложечной области, боли (часто схваткообразные), урчание, вздутие, повышенная или пониженная кислотность или полное ее отсутствие (ахилия). Эти болезненные ощущения часто возникают и проходят, в зависимости от состояния нервной системы и независимо от количества и качества пищи. Течение болезни зависит от устранения причин, вызвавших заболевание, и от состояния нервной системы.

**Распознавание и с.** Исключить органические заболевания желудка (катарры, изъязвление, рак, опущение и расширение желудка).

**Лечение.** Укрепление нервной системы: отдых в санатории или в сельских условиях, занятия физкультурой (купанье, лыжи, гребля и пр.), физиотерапевтические процедуры (души, ванны). Диета — в зависимости от функциональных расстройств: пища должна быть питательной и разнообразной, избегать ненужных ограничений. Лекарства: препараты валерианы, брома, люминала; при повышенной кислотности — щелочи, белладонна, атропин; при пониженной — соляная кислота, пепсин, горечи (см. *Гастрит хронический*).

Rp. In. rad. Valerianae ex 8,0—200,0 Natrii bromidi 8,0 Codeini phosphorici 0,15 MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Up. Luminali 0,05  
D, t. d. N. 6 in tabul.  
S. По 1—2 таблетки в день

**НЕВРОЗ КИШЕЧНИКА.** Причиной те же, что и при неврозах желудка (см.). Под влиянием нервных и психических факторов могут возникнуть различные функциональные нарушения.

Под влиянием страха, волнения появляются поносы (усиление кишечной перистальтики). Психические и нервные факторы ведут и спазмам кишечной мускулатуры (спастические запоры, боли в животе, значительный метеоризм).

При распознавании чистых неврозов нужно исключить различные органические заболевания кишечника.

Лечение (см. *Невроз желудка, поносы, запоры*).

**НЕВРОЗ ПИЩЕВОДА. СПАЗМ ПИЩЕВОДА (OESOPHAGOS-PASMUS).** Невроз пищевода проявляется спастическими сокращениями гладкой мускулатуры пищевода. Причины те же, что и при других неврозах внутренних органов. Иногда появлению спазмов способствуют рефлексы, исходящие из пищевода при торопливой еде, при проглатывании больших кусков непрожеванной пищи и пр.

**Симптомы и течение.** При спазмах затруднение глотания и прохождения пищи; иногда она временно совершенно



по проходит. Б о л и за грудиной и с р ы г и в а н и я проглоченной пищей.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Отличать от органических сужений (рубцовое сужение после ожогов, рак пищевода, сдавленно пищевода). Спазмы непостоянны, временны, не зависят от качества пищи, иногда труднее проходит жидкая пища, нежели более твердая. Часто спазмы возникают под влиянием переживаний, волнений и пр.

**Л е ч е н и е .** Как антиспазматическое средство хорошее действие оказывает атропин в сочетании с папаверином.

Rp. Atropini sulfurici 0,03  
Papaverini hydrochlorici 1,2  
Extr. rad. Valerianae  
(I. s. ut 1. pil. N. 30  
MDS. По 1 пилюле 2 раза в день за час до еды

В остальном лечение см. *Неврозы желудка и сердечно-сосудистые.*

**НЕВРОЗЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ.** Различные семейные конфликты, неправильный образ жизни, психические переживания и травмы, тяжелое нервное и психическое переутомление играют большую роль в развитии сердечно-сосудистых неврозов. Характер работы также имеет некоторое значение в этиологии неврозов, если работа связана с постоянным умственным напряжением, волнениями, ночными занятиями и пр. Привычные интоксикации служат благоприятной почвой для развития сердечно-сосудистых неврозов: курение табака, злоупотребление алкоголем, крепким чаем и кофе. К сосудистым неврозам (аппоневрозам) можно отнести гипертоническую болезнь в первоначальной стадии, когда в сосудах нет патолого-анатомических изменений, и приступы стенокардии без склеротических изменений в коронарных артериях.

Различные функциональные нарушения желез внутренней секреции, которые тоже регулируются центральной нервной системой, могут вызывать сердечно-сосудистые неврозы.

« Так, при повышенной функции щитовидной железы (г и п е р т и р е о з), при дисфункции половых желез (к л и м а к с) отмечаются значительные функциональные расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** У больных наблюдается сердцебиение, тахикардия, н о б л с д н е п и т о лица, и о х о л о д а н и е рук и ног. При повышении тонуса блуждающего нерва, наоборот,— б р а д и к а р д и я, о б щ а я с л а б о с т ь, г о л о в о к р у ж е н и я, г о л о в н ы е боли, боли в области сердца, п о к р а с н е н и е лица, п о в ы ш е н н а я потливость.

Иногда боли в области сердца довольно мучительны и напоминают стенокардию. Эти явления вызываются чувством страха, испуга, различными волнениями. У таких больных под влиянием психических травм, различных неприятностей иногда бывают с е р д е ч н ы е п р и п а д к и, преимущественно у женщин. У больного появляется сердцебиение, боли в области сердца, общая

слабость; наблюдается побледнение кожи, похолодание конечностей, озноб, а иногда и обморок.

**О б ь е к т и в н о :** размеры сердца нормальны, тоны ясные, пульс неустойчив, легко возбудим, но нормального наполнения и напряжения; кровяное давление иногда повышено; при спокойном состоянии больного оно может стать нормальным.

**Л е ч е н и е .** Все эти явления не опасны для жизни больных, но они мучают их, угнетают, даже делают больных временно нетрудоспособными. Если найден этиологический момент, вызывающий болезненные явления, то его нужно по возможности устранить.

В основном лечение связано с воздействием на всю нервную систему и в первую очередь на психику больного. Установление режима: правильный образ жизни, запрещение потребления алкоголя, крепкого чая и кофе, курения. Лечение гипертиреоза, заболеваний женских половых органов и органов пищеварения. Занятия физкультурой и физиотерапевтические процедуры (солнечные и воздушные ванны, обтирания, души, морские купанья). Успокаивающие нервную систему средства: бромистые препараты, валериана, люминал, папаверин, кальций.

Rp. T-rae Valerianae simplicis 20,0 DS.  
По 20 капель 2—3 раза в день

Rp. Bromurali 0,3  
D. L. d. N. 6 in tabul.  
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Rp. Inf. rad. Valerianae G.0-200,0 Natrii bromati  
fi,0 Calcii chlorati 10,0 Codoini phosphoidei  
0,15 MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Campborae monobromatae 0,2  
Papaverini hydrochlorici Luminali  
aa 0,02 M. f. pulv. D. I. d. N. 12 DS.  
По 1 порошку 3 раза в день

#### НЕКРОНЕФРОЗ, СУЛЕМОВАЯ ПОЧКА (NECRO NEPHROSIS).

Характеризуется значительными дистрофическими изменениями в почках с некрозом почечных канальцев. Развивается чаще при различных тяжелых отравлениях ртутными препаратами, крепкими кислотами, новарсенолом и другими ядами. Типичная картина некронефроза наблюдается при отравлении сулемой.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Обычно, наряду с другими симптомами!! отравления, развиваются явления острого поражения почек: уменьшается количество мочи, в ней появляется белок, цилиндры, небольшое количество эритроцитов и лейкоцитов. В тяжелых случаях через 2—3 дня развивается анурия, повышается артериальное давление, наступает азотемическая уремия.

**Л е ч е н и е .** Применяются средства, указанные в таблице первой помощи при отравлениях ртутью, кислотами и другими ядами.

Явления со стороны почек и уремия лечатся обычными методами (см. *Нефриты острый и хронический*).

**НЕСАХАРНОЕ МОЧЕИЗЖУРЕНИЕ** см. *Диабет несахарный*.

**НЕФРИТ ОСТРЫЙ (NEPHRITIS ACUTA)**. Причина — инфекционные болезни: чаще скарлатина и ангина, дифтерия, корь, сепсис, брюшной тиф и др. Возбудитель — главным образом стрептококк. Предрасполагающая причина — охлаждение.

Острый нефрит следует рассматривать как аллергическую реакцию организма на болезнетворное начало. Ведущую роль в развитии аллергической реакции играет изменение реактивности центральной нервной системы.

**Симптомы и течение.** Характерны три основных симптома: гематурия (кровавая моча), отеки и гипертония (повышенное артериальное давление). Выделение мочи значительно уменьшается, в тяжелых случаях может совершенно прекратиться (анурия). •Кроме эритроцитов, в моче обнаруживается белок (2—4‰, а иногда и больше). В некоторых случаях острый нефрит протекает со значительными нефротическими (см. *Нефроз*) симптомами: значительные отеки, в моче большое количество белка — до 10—15‰, много эпителиальных, зернистых, а иногда и восковидных цилиндров.

У больных наблюдается общая слабость, плохой аппетит, головные боли, иногда тошнота и рвота; нередко наблюдается эклампсия (экламптическая, судорожная уремия), которая сопровождается преимущественно мозговыми симптомами, вследствие спазма мозговых сосудов (ангиоспазм) и отека мозга: резкая головная боль, тошнота, рвота и судороги, похожие на приступы эпилепсии, затемнение сознания и затем полная его потеря; зрачки расширены, изо рта выделяется пена. Отдельные приступы эклампсии большей частью заканчиваются благополучно. Ангиоспазмы образуются также в сосудах глазного дна (ангиоспастический неврит), что ведет к ослаблению зрения. При значительном уменьшении количества мочи, особенно при анурии, может наступить истинная азотемическая уремия (см. *Нефрит хронический*). Острый нефрит — тяжелое заболевание, продолжающееся 1—2 месяца, а иногда и больше; может перейти в хронический нефрит.

**Лечение.** Постельное содержание. Диета: ограничение количества воды, поваренной соли и белков; назначается молочно-растительная пища, всевозможные каши, хлеб, сливки, сливочное масло, овощи и фрукты, за исключением раздражающих почки (хрен, редька и др.). В тяжелых случаях назначают сахарные дни (дается только 150—200 г сахара в сутки) в течение 1—2—3 дней. Назначают также фруктовые и молочные дни. При явлениях эклампсии делают кровопускание, спинномозговую пункцию.

Внутривенно или внутримышечно вливают сернокислую магнезию, внутривенно глюкозу.

Rp. Sol. Magnesii sulfurici 5% 10,0 D. t.  
d. N. 6 in ampullis.

S. По 5—10 мл внутривенно. Внутримышечно можно вводить до 25 мл

р

Rp. Sol. Glucosi 40% 20,0 D. t. d.  
N. 4 in ampulis. S. По 20 мл  
внутривенно

Когда острые явления прошли, дают в небольшом количестве вареное мясо или рыбу и прибавляют в пищу немного соли. При отеках — горячие водяные или суховоздушные ванны. Из лекарств: не раздражающие почки мочегонные (кофеин, диуретин). При ослаблении сердца — наперстянка (*Digitalis*), горицвет (*Adonis*), строфант.

**НЕФРИТ ОЧАГОВЫЙ (NEPHRITIS INSULARIS)**. Вызывается инфекцией; обычно является осложнением других, главным образом септических, заболеваний (гнойное воспаление миндалин, полостей носа, червеобразного отростка слепой кишки, септический эндокардит и др.). Бактерии с током крови попадают в почки и вызывают ограниченные участки (очаги) воспаления.

**Симптомы и течение.** Симптомы наблюдаются только со стороны мочи: белок (в небольшом количестве) и гематурия, иногда боли в области почек. Функция почек не нарушена, гипертонии и отеков не бывает. Течение болезни зависит от основного заболевания.

**Лечение** основного заболевания. Диета см. *Нефрит острый*.

**НЕФРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (NEPHRITIS CHRONICA)**. Острый нефрит может перейти в хронический при наличии в организме инфекционных очагов, недостаточном лечении острого нефрита и неблагоприятных трудовых и бытовых условиях. Гипертрофия сердца, развивающаяся на почве гипертонии, ведет к постепенному перерождению сердца и ослаблению сердечной мышцы. Почечная ткань постепенно атрофируется, почка сморщивается (вторично сморщенная почка), способность со выводить продукты белкового обмена (азотистых веществ) все уменьшается, начинает развиваться уремия (истинная азотемическая).

**Симптомы и течение.** Белок и кровь в небольшом количестве (микрогематурия), моча с низким удельным весом. Отеки небольшие или совсем отсутствуют. Развивается малокровие, общая слабость, быстрая утомляемость, появляются частые головокружения и головные боли. Вследствие спазма сосудов глазного дна (ангиоспастический неврит) ослабевает зрение, а впоследствии может наступить слепота. Основным симптом — гипертония, ведущая к гипертрофии сердца. При азотемической уремии: головная боль, тошнота, слабость, апатия, сонливость; затем появляется рвота, поносы, судороги; дыхание, рвотные массы и испражнения пахнут мочой; характерно сужение зрачков. Если явления уремии нарастают, то больные впадают в коматозное состояние (уремическая кома). Больные гибнут от уремии или от ослабления сердечной мышцы.

**Лечение.** Молочно-растительная диета, запрещаются спиртные напитки. Мясо и рыба только в вареном виде и в небольшом количестве. При низком удельном весе мочи нельзя ограничивать питье (для выведения продуктов обмена).

Регулировать рабочий день, избегать охлаждения и сырости, чтобы не вызвать обострения болезни. Жить и работать обязательно в сухом и теплом помещении. Климатическое лечение в местностях с сухим, жарким климатом (Ашхабад, Байрам-Алп).

При самых начальных признаках уремии уложить больного в постель; совершенно устранить мясные продукты и яйца; ограничить продукты, богатые белком (творог, сыр, бобы, горох, фасоль, чечевица, грибы), а при явлениях ясно выраженной уремии совершенно запретить и эти продукты, назначив почти исключительно углеводистую пищу (сахар, глюкоза). При рвоте — глотание кусочков льда. При резких головных болях — лед на голову, к рукам и ногам грелки или горчичники. Во время судорог — хлоралгидрат (по 1,0 2 раза в день в молоко) или впрыскивание морфина или омнопона.

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici 1% 1,0 D. t. d.

N. 6 in ampulis S. По 1 ампуле под кожу

Rp. Sol. Onmoponi 2% 1,0 D. t. d.

N. 6 in ampulis S. По 1 ампуле под кожу

Во время бессознательного состояния (при уремической коме) — хлоралгидрат в клизмах.

Rp. Chlorali hydrati 2,0  
Mucilaginis Salop Aq.  
destill. aa 25,0 MDS.  
Для клизмы

Кровопускание (от 200 до 500 мл) с последующим введением глюкозы под кожу или внутривенно. Горячие водяные и суховоздушные ванны, вызвать потоотделение, выводящее продукты белкового распада (азотистые вещества).

**НЕФРОАНГИОСКЛЕРОЗ (NEPHROANGIOSCLEROSIS). НЕФРОСКЛЕРОЗ. СКЛЕРОЗ АРТЕРИОЛ (МЕЛКИХ АРТЕРИЙ), ПОЧЕК (ПЕРВИЧНО СМОЩЕННАЯ ПОЧКА).** Нефроангиосклероз является копочной (третьей) стадией гипертонической болезни (см.). Причиной нефроангиосклероза является гипертоническая болезнь.

**Симптомы и течение.** Основным симптом — гипертония (повышенное артериальное давление) и последующая гипертрофия сердца (расширение сердечной тупости влево, акцент на втором тоне аорты).

В далеко зашедших случаях наступают явления недостаточности почек. Почки теряют способность к концентрации, в организме накапливаются продукты обмена, что, в конце концов, ведет к уремическому состоянию (см. *Нефрит хронический*). Нефроангиосклероз часто развивается очень медленно; больные живут годами, пока не наступают явления почечной недостаточности, которые нарастают тоже очень медленно. В некоторых случаях так называемого злокачественного нефроангиосклероза (злокачественной формы гипертонической

**болезни**) болезнь прогрессирует чрезвычайно быстро, быстро нарастают явления почечной недостаточности, и больные в течение 1—2 лет погибают от уремии или от сердечной недостаточности.

**Распознавание.** Нужно отличать от гипертонической болезни без почечных явлений и от хронического нефрита.

**Лечение** см. *Гипертоническая болезнь, ясчснпс. Атеросклероз, лсчснпс. Нефрит хронический, лсчснпс.*

**НЕФРОЗ (NEPHROSIS).** Нефроза́ми называются дистрофические изменения в почках, при которых наблюдается перерождение почечных канальцев. К острым нефрозам относятся: лихорадочный нефроз и некронефроз (см.). К хроническим нефрозам относятся лн-поидный и лигноидно-амилоидный нефрозы (см.).

Лихорадочный нефроз наблюдается при многих инфекционных заболеваниях: тифах, крупозном воспалении легких, дифтерии и др. Он обнаруживается только при исследовании мочи, так как отеков, повышения артериального давления и других симптомов почечного заболевания не наблюдается. В моче обнаруживают белок, почечный эпителий и цилиндры. Лихорадочный нефроз или лихорадочная альбуминурия обычно проходят вместе с лихорадочным состоянием без особого лечения.

**НЕФРОЗ ЛИПОИДНО-АМИЛОИДНЫЙ.** Этот нефроз является сочетанием липоидного перерождения почек с отложением амилоида в почках и других органах.

Причиной являются продолжительные нагноительные процессы в костях (туберкулез костей и суставов), легких (хронический кавернозный туберкулез легких, бронхоэктазип, хронический абсцесс легких), в придаточных полостях носа и т. д.

**Симптомы и течение.** В начале болезни отмечается только небольшая альбуминурия. Затем в основном появляются те же симптомы, как и при липоидном нефрозе(с.). Часто впоследствии наблюдаются амилоидоз печени, селезенки, кишечника (увеличение печени, селезенки, упорные поносы).

**Распознавание.** Наиболее трудно отличить от чистого липоидного нефроза, тем более что последний обычно сочетается с амилоидозом. Наличие амилоидоза в других органах указывает на липоидно-амилоидный нефроз.

**Течение и лечение** см. *Нефроз липоидный.*

**НЕФРОЗ ЛИПОИДНЫЙ (NEPHROSIS LIPOIDEA).** Причиной бывают хронические гнойные заболевания, сифилис, малярия, кавернозный туберкулез легких и др. В чистом виде липоидный нефроз встречается редко, обычно — в сочетании с амилоидным (см. *Нефроз липоидно-амилоидный*).

**Симптомы и течение.** Значительные отеки всего тела, отеки полостей (асцит, гидроторакс). Кожа бледная, сухая, блестящая. В моче много белка (20—40‰ и больше), в осадке находится много лейкоцитов, клеток почечного эпителия и различных цилиндров: эпителиальных, зернистых, гиалиновых, иногда и воскопидных (см. *Лабораторные исследования*). Больные жалуются только на значительные отеки, которые их стесняют и беспокоят. Никаких болей и неприятных ощущений обычно не наблюдается.

Больные погибают от каких-либо осложнений, чаще от присоединившихся инфекционных заболеваний или недостаточности почек.

Л о ч е п и е направлено против основного заболевания (удаление гнойных очагов, лечение сифилиса, малярии). Постельный режим. Тщательный уход, особенно за кожей, чтобы предупредить образование пролежней. Основной метод лечения — диета: ограничение жидкости, пища бессолевая, но богатая белком. Мочегонные: меркузал, хорошо — тиреоидин (по 0,1 дпа-три раза в день).

Rp. Mercusali 2,0

D. t. d. N. 6-й ашр.

S. По 1 ампуле внутримышечно один паз в 3—6 дней

Для усиленного потоотделения применяют горячие водяные и суховоздушные ванны. Лечение в сухом теплом климате (Ашхабад, Байрам-Али).

НЕФРОПТОЗ см. Почка опущенная.

ОБМОРОК см. Сердечно-сосудистая недостаточность острая и гл. XXI. Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях.

ОЖИРЕНИЕ (ADIPOSITAS). Причины: потребление чрезмерного количества пищи, особенно высококалорийной, сидячий образ жизни; отсутствие физического труда, нарушение жирового обмена, уменьшение процессов сгорания в тканях (пониженный обмен веществ).

В понижении обмена веществ большую роль играет нарушение функции некоторых желез внутренней секреции (половых, щитовидной и особенно мозгового придатка). Наиболее часто ожирение, особенно у женщин, происходит от понижения или прекращения функции половых желез (климакс); резко выражено ожирение, при нарушении функции гипофиза. Обмен веществ, в том числе и жировой, регулируется центральной нервной системой (подкорковыми центрами, находящимися под влиянием коры головного мозга). Различные формы эндокринного ожирения тоже возникают вследствие нарушений центральной нервной системы, регулирующей также и функции эндокринных желез. Иногда наблюдается сочетание обильного потребления пищи с нарушением жирового обмена.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Значительные отложения жира в подкожной клетчатке, а также в брюшной полости (в сальнике), в сердечной мышце, около почек и т. д. Отсюда и различные симптомы со стороны внутренних органов и в первую очередь явления сердечной недостаточности: одышка, расширение сердца, глухие топы; запоры, геморрой; быстрая утомляемость; понижение полового чувства. Ожирение — болезнь хроническая, все явления нарастают постепенно.

Л е ч е н и е. Запрещается употребление спиртных напитков. Ограничивается введение всякой жидкости. Пища должна быть малокалорийная, богатая растительной клетчаткой; значительное ограничение жиров, а затем и углеводов (сладкие и мучнистые блюда). Необходимы прогулки, физический труд, занятия спортом при условии соответствующей их дозировки, водные процедуры (купанье, души, обтирания). Не допускать запоров. При сердечной недостаточ-



кости принимать соответствующие меры (см. Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая).

ОПУЩЕНИЕ ЖЕЛУДКА см. Гастроптоз.

ОПУЩЕНИЕ ПОЧКИ см. Почка опущенная.

ОТЕК ЛЕГКИХ (OEDEMA PULMONUM). При значительном ослаблении сердечной мышцы, особенно левого желудочка, в полости легочных альвеол начинает пропотевать отечная жидкость (трансудат). Отек начинается с нижних отделов обоех легких. Слизистая оболочка бронхов тоже отекает (набухает).

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Сильная одышка, затрудненное, громкое, kloкочущее дыхание, цианоз, похолодание конечностей. С кашлем выделяется жидкая, пенная, серозно-крово-чистая мокрота. Небольшое притупление перкуторного звука, сначала только в нижних отделах легких. При аускультации — обильное количество разнокалиберных влажных и сухих хрипов. Пульс частый, малого наполнения, иногда аритмичный. Тоны сердца глухие, часто совсем не удается прослушать из-за шумного дыхания и хрипов.

Л е ч е н и е. Приподнятое удобное положение больного, свежий воздух, полный покой. Отвлекающие средства: банки, горчичники, к ногам грелки, кровопускание (300—600 мл), вдыхание кислорода.

Как мера первой помощи хорошее действие оказывает перетяжка рук и ног: па руки и ноги накладываются резиновые жгуты так, чтобы сдавить только вены, что проверяется по пульсу (пульс на лучевой артерии и на тыльной артерии стопы не должен исчезать). Происходит застой венозной крови в конечностях благодаря отвлечению крови от внутренних органов, в том числе и от легких. Через 30—45 минут постепенно, по очереди, освобождают конечности от жгутов.

Применение возбуждающих и сердечных средств: камфора, кофеин, стрихнин, адреналин, наперстянка (Digitalis) и ее производные. Внутривенно глюкоза с'o строфантом (см. Сердечно-сосудистая недостаточность).

Rp. Sol. Glucosi 40% 20,0 •

Sol. Strophanthini 0,1% 0,25

Steriliscitur!

MDS. Для внутривенного вливания

ОТЕКИ БЕЗБЕЛКОВЫЕ. ОТЕКИ ГОЛОДНЫЕ. ОТЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ см. Алиментарная дистрофия.

ОЧАГОВАЯ ПНЕВМОНИЯ см. Пневмония очаговая.

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ. Внезапно наступающие учащения сердечных сокращений (тахикардия), протекающие приступами (пароксизмами), которые возникают большей частью при резком раздражении симпатического нерва.

Причинами являются различные органические заболевания сердца: митральный порок сердца, кардиосклероз, инфаркт миокарда. Приступы могут возникать и рефлекторно при здоровом сердце, вследствие раздражений, идущих с других органов, например, при заболеваниях желчного пузыря.

**Симптомы и течение.** Основной симптом — резкое учащение пульса — до 150—200 ударов в минуту и даже больше. Сердцебиение и чувство стеснения в груди, общая слабость, головокружение, вплоть до обмороков. Пульсация всего сердца и шейных вен.

Приступы длятся минуты или часы; редко — дни и даже недели. Приступы возникают внезапно и так же внезапно прекращаются.

**Лечение.** Приступ часто можно прекратить рефлекторным раздражением блуждающего нерва путем сильного одновременного давления на оба глазных яблока. Придавливая с одной стороны сонную артерию к позвонку на уровне верхнего края щитовидного хряща в течение 10 секунд, тоже можно купировать приступ. Рвотные движения иногда прекращают приступ. Из лекарств применяют хинидияп, хинин, наперстянку, строфант.

Rp. Chinidini sulfurici 0,2 D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Pulv. fol. Digitalis 0,05 Chin in i hydrochlorici 0,1 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 in oblati Po 1

облатке 3 раза в день

Rp. Sol. Strophantini 0,1% 0,25

Sol. Glucosi 40% 20,0

Sterilisetur!

MDS. Для внутривенного вливания (вливать медленно)

**ПЕЛЛАГРА (PELLAGRA).** При чинной болезни является отсутствие или недостаток в пище никотиновой кислоты (противопеллагрозного витамина PP). Иногда болезнь развивается, когда клетки организма теряют способность усваивать необходимый для них витамин.

**Симптомы и течение.** Характерны три основных симптома: дерматит (воспаление кожи), диарея (поносы) и деменция (слабоумие). Весной от солнечных лучей кожа на открытых частях тела, лице, шее, тыльной стороне рук, а иногда и ступнях ног становится красной, как бы обожженной, болезненной, появляется зуд. Впоследствии кожа шелушится, трескается, становится шершавой, коричневой вследствие отложения пигмента; па руки как будто надеты перчатки («пеллагрозные перчатки»). Затем появляются поносы и иногда развивается слабоумие. Больные ощущают жжение во рту, они теряют аппетит, постепенно нарастает общая слабость и истощение организма. Пеллагра протекает хронически, иногда в течение нескольких лет. В легких случаях наступает полное излечение, в тяжелых — больные гибнут от резкого истощения.

**Лечение.** Специфическим средством является никотиновая кислота, которая в некоторых случаях совершенно излечивает пеллагру. Никотиновую кислоту дают в чистом виде, в порошках и в виде внутривенных вливаний.

Rp. Ac. nicotini 0,05 Sacchari albi 0,3 M. f.

pulv. D. t. d. N. 10 S. По 1 порошку 3

раза в день

Rp. Sol. acidi nicotini 1% 10,0

Sterilisetur!

DS. Ежедневно по 5—10 мл внутривенно или внутримышечно

Пищу нужно давать, богатую витамином PP и полноценными белками (молоко, яйца, пивные и пекарские дрожжи, печень, почки, мясо и рыба, яблоки, помидоры, капуста, морковь, картофель, грибы).

**ПЕРИКАРДИТ. ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОСЕРДЕЧНОЙ СУМКИ (PERICARDITIS).** Почти всегда вызывается инфекцией, чаще ревматической или туберкулезной, реже наблюдается при скарлатине/тифах и других инфекционных заболеваниях. Иногда воспаление передается с легких или плевры. Перикардит бывает сухой, или фибринозный, и выпотной (экссудативный), который в свою очередь может быть серозным или гнойным.

**Симптомы и течение.** При остром перикардите температура всегда повышена; высота и характер ее зависят от основного заболевания; при туберкулезном, особенно септическом, перикардите температура ремиттирующая (после Зноющая). При сухом перикардите: боль в сердце, выслушивается шум трения перикарда. Экссудативный перикардит сопровождается стеснением в груди и удушьем; сердечный толчок исчезает, тоны сердца становятся глухими, пульс частым и слабым; при перкуссии сердечная тупость увеличена во всех направлениях. Вследствие сдавления сердца экссудатом могут развиваться явления сердечной недостаточности (одышка, цианоз, отеки). От нарастающей сердечной недостаточности больной может погибнуть. Иногда в результате перикардита наступает сращение листков перикарда, вследствие чего работа сердца затрудняется и постепенно развиваются симптомы сердечной недостаточности.

**Распознавание.** Сухой перикардит иногда приходится отличать от сухого плеврита (см. *Плеврит сухой*). Экссудативный перикардит можно смешать с заболеваниями сердца, при которых наблюдается значительное увеличение его размеров (пороки сердца, кардиосклероз).

**Лечение.** Абсолютный покой, постельный режим. При болях — лед на сердце, наркотические средства (кодеин, днотин, морфин) или успокаивающие (бромиды, люминал). При ревматическом перикардите — салицилаты (салициловый натрий, аспирин, пирамидон). При туберкулезном перикардите — соответствующие режим и лечение. При экссудативном перикардите ограничивают питье и дают мочегонные (например, диуретин). Когда эссудат вызывает значительную недостаточность сердца, приходится делать прокол перикарда и выпускать жидкость (операцию может производить только врач). При сердечной недостаточности применяются различные сердечные средства (камфора, кофеин, стрихнин) (см. *Плеврит п Сердечно-сосудистая недостаточность*).

ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ см. *Анемия злокачественная.*

ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА см. *Желчнокаменная болезнь.*

ПНОПНЕВМОТОРАКС см. *Пневмоторакс.*

ПИЩЕВОДА ВОСПАЛЕНИЕ (OESOPHAGITIS). Причина — ожоги горячей пищей, спиртом, отравление крепкими кислотами и щелочами, повреждения пищевода инородными телами (рыбья кость и др.).

Симптомы и течение. Боль за грудиной, обильное слюнотечение, затруднение глотания. В остром периоде больные иногда совершенно не могут принимать пищи, даже жидкой. Тогда наблюдается срыгивание пищи, выделение слизи с гноем и даже кровью. Воспаление может пройти бесследно, но при значительных ожогах наблюдается гнойное воспаление с последующим омертвением ткани. Заживление происходит путем рубцевания, которое может вызвать стойкое сужение или даже полное зарастание пищевода.

Лечение. При отравлениях кислотами и щелочами как можно скорее произвести промывание желудка. Затем дают пить слабый раствор кислоты, если произошло отравление щелочами, и жженую магнезию, смешанную с водой, при отравлениях кислотами,

Rp. Sol. Ac. acetici 1% 200,0

DS. Через 5 минут по 1 столовой ложке

Rp. Ac. citrici 1,0 Aq. destill. 200,0 MDS. Через 5

минут по 1 столовой ложке

Rp. Magnesiae ustae 30,0 Aq. destill. 200,0

MDS. Через 5 минут по 1 столовой ложке. Перед употреблением взбалтывать

Покойное положение больного. На грудь — пузырь со льдом, глотание кусочков льда, мороженого, холодные (со льда) сливки или молоко. Внутрь масляные эмульсии.

Rp. Emuls. Amygdalarum dulcium 200,0 DS.

Через 2 часа по 1 столовой ложке

При невозможности принимать даже жидкую пищу — подкожные вливания физиологического раствора, раствора Рингера или раствора глюкозы (изотопического). Эти же растворы в больших количествах можно вводить при помощи капельных клизм.

Rp. Sol. Glucosi 5% 500,0 Sterilisetur!

DS. Для подкожного вливания

Rp. Sol. Natrii chlorati physiologicae (0,85%) 600,0

Sterilisetur! DS. Для подкожного вливания

Rp. Natrii chlorati 9,0 Kalii chlorati Calcii chlorati Natrii bicarbonici aa 0,2 Aq. destill. 1000,0 Sterilis. tur!  
MDS. Рингеровский раствор для подкожного вливания

Диета. После исчезновения острых явлений — слизистые и маслянистые продукты в тепловатом виде, рисовые и овсяные отвары со сливочным маслом, жидкие яйца, каши с маслом и молоком, желе, кисели. Рубцовые сужения лечат бужированием. При полной непроходимости пищевода — операция.

ПИЩЕВОДА СПАЗМ см. *Вегетаризм пищевода.*

ПИЩЕВОДА СУЖЕНИЯ (STENOSIS OESOPHAGES). Сужения пищевода могут быть временные — от спазмов (см. *Неврез пищевода*) и постоянные органические — рубцы после воспаления (см. *Пищевода воспаление*), рак (вaya опухоль (см. *Рак*, гл. VI, *Хирургические болезни*); сужение пищевода может быть от сдавления окружающими органами и тканями: опухолью средостения, аневризмой аорты и пр. Течение и лечение см. указанные заболевания.

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ см. гл. II. *Инфекционные болезни, Гастрит острый, Гастроэнтероколит* и гл. XXI. *Первая помощь при различных заболеваниях и отравлениях.*

ПИЭЛИТ. ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКИ (PYELITIS). Причина — инфекция, которая может проникнуть нисходящим путем через почки (кишечная палочка, брюшнотифозная и гриппозная инфекция, гнойеродные бактерии и др.) и восходящим — через мочевые пути (гонорройная инфекция). Почечные камни также могут вызвать воспаление лоханок.

Симптомы и течение. Острый пиелит сопровождается повышенной температурой, обычно послабляющей (при гнойном пиелите температура доходит до 40°). Боль в области почек (в пояснице), часто отдающая в пах или половые органы. Положительный симптом Пастернацкого. Моча мутная, содержит большое количество лейкоцитов. Острые пиелиты, возникшие при инфекционных болезнях, длятся несколько недель в проходят бесследно. Пиелиты при беременности часто проходят после родов. Острые пиелиты при недостаточном лечении, а также если, не устранены вызвавшие их причины, часто переходят в хронические. Пиелиты, вызванные почечными камнями или гонорройной инфекцией, протекают хронически, если не проводится соответствующее лечение.

Распознавание. Нужно отличать от почечнокаменной болезни и воспалительных заболеваний почек.

Лечение. Постельный режим, обильное питье. Пища не раздражающая, преимущественно молочно-растительная. При болях — грелки, согревающие компрессы, теплые ванны. Лучшим средством при остром пиелите, особенно гнойеродной этиологии, в том числе и гонококковой, являются сульфаниламидные препараты: стрептоцид по 0,5 шесть раз в день, сульфазол (сульфидип и др.) по 1,0 четыре

раза в сутки (см. *Пнемония крупозная*). Применяют также пенициллин. (200 000—400 000 единиц в сутки) (см. *Абсцесс легких*) и дезинфицирующие средства (салол, уротропин по 0,5 три раза в день) вместе с минеральными щелочными водами (боржом, эссенуки). Rp. Saloli 0,5

D. t. d. N. 12

S. По одному порошку 3 раза в день

Уротропин лучше применять внутривенно.

Rp. Sol. Urotropini 40% 10,0 Sterilisetur! DS. По 5—10 мл внутривенно 1 раз в день

Назначают отвар медвежьего ушка (мочегонное средство) внутрь:

Rp. Decocti folii Uvae Ursi ex 10,0—200,0 DS.  
Через 2 часа по столовой ложке

Если пиелит вызван гонореей или почечным камнем, нужно лечить эти заболевания. Иногда при хронических пиелитах путем катетеризации мочеточников промывают почечные лоханки разными дезинфицирующими растворами.

Rp. Argenti nitrici 0,1

Aq. destill. 100,0

Sterilisetur!

MDS. 5—10 мл вводить через катетер в почечную лоханку

**ПЛЕВРИТ ВЫПОТНОЙ, ЭКССУДАТИВНЫЙ, СЕРОЗНЫЙ (PLEURITIS EXSSUDATIVA SEROSA).** При экссудативном (выпотном) плеврите в полости плевры обычно накапливается серозный экссудат — прозрачная жидкость светложелтого или желто-зеленоватого цвета. Наиболее часто экссудативные плевриты бывают туберкулезного происхождения, затем они наблюдаются при остром ревматизме и воспалении легких.

**Симптомы и течение.** Первые признаки: боли в грудной клетке при вдохе и кашле, повышение температуры, общая слабость, потеря аппетита. Больной лежит обычно на больном боку. Температура постепенно повышается и может дойти до 39—40°. При больших экссудатах значительная одышка. При осмотре отмечается выпячивание боковой стороны грудной клетки и отставание дыхания. Голосовое дрожание ослаблено или отсутствует. Тупой перкуторный звук, первоначально появляющийся в нижних частях полости плевры. При выслушивании в начале болезни шум трения плевры, а по мере накопления жидкости — ослабленное дыхание или его отсутствие. Экссудатом сердце смещается в здоровую сторону. Ревматические и послеппневмонические плевриты могут закончиться в 1—2 недели, туберкулезные — в среднем протекают 4—6 недель.

**Распознавание.** В начале болезни легче всего смешать экссудативный плеврит с крупозным воспалением легких,

затем с очаговой пневмонией, гидротораксом; с целью распознавания, а также определения состава жидкости делают пробный прокол 10—20-граммовым шприцем, вводя иглу в шестое-восьмое межреберье по задней подмышечной или лопаточной линии на месте тупости.

**Лечение.** Постельное содержание, согревающие компрессы, банки, горчичники. Внутрь — салициловый натрий (по 1 г 3—6 раз в день), аспирин (по 1 г 4 раза в день), пирамидон (по 0,5 г три раза в день).

В период рассасывания для повышения диуреза назначают диуретин (по 0,5 г три-четыре раза в день).

При туберкулезных, особенно геморрагических, экссудатах — хлористый кальций.

Rn. Sol. Calcii chlorati 10% 200,0

DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 10,0

Sterilisetur! DS. 10 мл внутривенно

При одышке, сильном кашле и болях — кодеин, героин, дионин.

Rp. Codeini phosphorici 0,02 Sacchari albi 0,3 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 3 раза в день Rp. Sol. Dionini 2% 20,0

DS. По 15 капель 3 раза в день

Rp. Heroini hydrochlorici 0,003 Sacchari albi 0,3 M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S.

По 1 порошку 3 раза в день

При ослаблении сердечной деятельности — возбуждающие (кафедра, кофеин). В период выздоровления больные должны находиться в постели даже при нормальной температуре, пока в полости плевры находится жидкость. Имея в виду туберкулезную этиологию плевритов, нужно проводить общеукрепляющее лечение: усиленное питание, свежий воздух и пр. После больничного лечения полезно направлять больных для дальнейшего лечения в санаторий.

Если рассасывание жидкости задерживается или большой экссудат вызывает одышку и затрудняет работу сердца, его выкачивают; выкачивание желательно производить, когда температура у больного снизится или даже станет нормальной. Выпускать жидкость следует медленно и сразу не более 1—1,5 л.

**ПЛЕВРИТ ГНОЙНЫЙ. ЭМПИЕМА (PLEURITIS PURULENTA. ЭМПИЕМА).** Возбудители — стрептококк, стафилококк и пневмококк, туберкулезная палочка. Эмпиема возникает при ранении грудной клетки, абсцессе и гангрене легкого, при пневмонии. Заражение плевры происходит и с других соседних органов (диафрагма, средостение и т. д.), а также гуморальным путем (сепсис и др.).

**Симптомы и течение.** Острый гнойный плеврит протекает с высокой ремиттирующей или гектической температурой, ознобами и потами. Общая слабость, потеря аппетита, нарастающая анемия и похудание, нейтрофильный лейкоцитоз. При пробном проколе плевры — гнойная жидкость. При физических методах исследования те же данные, что и при экссудативном плеврите. Если эмпиема своевременно не вскрыта, то гной может прорваться через бронх, через кожу, в полость брюшины и т. д. Туберкулезные гнойные плевриты протекают с субфебрильной, а иногда и нормальпой температурой без резких явлений интоксикации; течение медленное и длительное.

**Распознавание** см. *Плеврит выпотной*. **Лечение.** При остром гнойном нетуберкулезном плеврите — резекция ребра и выпускание гноя с последующим дренированием полости плевры. В последнее время вслед за откачиванием гноя производится промывание полости плевры раствором пенициллина или грамицидина. При туберкулезных эмпиемах производят постепенное откачивание гноя без резекции ребра. Затем проводят общеукрепляющее лечение (см. *Туберкулез легких*).

При болях в груди, кашле, одышке, ослаблении сердца — лечение, как при выпотном плеврите (симптоматическое). **ПЛЕВРИТ СЕРОЗНЫЙ** см. *Плеврит выпотной*. **ПЛЕВРИТ СУХОЙ (PLEURITIS SICCА).** Чаще туберкулезного происхождения. Крупозное воспаление, абсцессы и другие заболевания легких часто поражают и прилежащую плевру.

**Симптомы и течение.** Боли в грудной клетке при дыхании и кашле, сухой кашель, повышение температуры. При перкуссии легких нет изменений; при выслушивании — шум трения плевры. Сухой плеврит протекает от нескольких дней до 2—3 недель, иногда тянется месяцами.

**Лечение.** Постельный режим, согревающие компрессы, банки, горчичники. Внутрь — салициловый натрий, аспирин, пирамидон. При болях и кашле — наркотические (героин, дионин) (см. *Плеврит выпотной*). При плевритах туберкулезного происхождения — общеукрепляющее лечение (см. *Туберкулез легких*).

**ПЛЕВРИТ ЭКССУДАТИВНЫЙ** см. *Плеврит выпотной*. **ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ** см. *Пневмония крупозная*.

**ПНЕВМОКОНИОЗ (PNEUMOCONIOSIS).** Пневмокониоз — болезнь легких, вызываемая проникновением в легочную ткань пылевых частичек. Имеет значение вдыхание неорганической пыли: угольной (антракоз), кремневой (силикоз), металлической (sideroz) и др. Наиболее распространенным видом пневмокониоза является силикоз, тем более что и угольная пыль содержит кварцевые частицы (силиций). Заболевают лица, длительно работающие на пылевых производствах. При значительном количестве пыли в бронхах часть ее, проникая в соединительную ткань, окружающую бронхи, альвеолы и в лимфатические узлы, вызывает в них воспалительные процессы с последующим разрастанием соединительной ткани (пневмосклероз). Пыль является причиной возникновения хронических бронхитов.

Предрасполагающие причины — заболевания легких и бронхов.

**Симптомы и течение.** Одышка, кашель сухой или влажный, мокрота, иногда с кровью; легкие эмфизематозно расширены, при перкуссии дают коробочный звук, дыхание ослабленное, жесткое, даже с бронхиальным оттенком.

Болезнь хроническая, начинается с едва заметных признаков и развивается в течение нескольких лет. Пневмокониоз приводит к хроническому бронхиту, эмфиземе легких, бронхоэктазам, пневмосклерозу и сердечной недостаточности (легочное сердце).

**Распознавание** на основании профессионального анамнеза. Необходимо дифференцировать от туберкулеза (отсутствие туберкулезных палочек, данные рентгенограммы).

**Лечение.** Чистый воздух, хорошее питание, достаточный отдых. Если болезнь ухудшается, следует переменить профессию. Лечение такое же, как развившегося хронического бронхита, эмфиземы, пневмосклероза, сердечной недостаточности (см. указанные болезни).

**Профилактика.** Улучшение условий труда и быта. Хорошая вентиляция на производстве; защита различными приспособлениями (респираторами) дыхательных путей от проникновения пыли: Пылеулавливание, мокрое бурение, медицинские осмотры рабочих через каждые три месяца.

**ПНЕВМОНИЯ АСПИРАЦИОННАЯ** см. *Пневмония очаговая*.

**ПНЕВМОНИЯ ВИРУСНАЯ** см. *Пневмония очаговая*.

**ПНЕВМОНИЯ КАТАРРАЛЬНАЯ** см. *Пневмония очаговая*.

**ПНЕВМОНИЯ КРУПОЗНАЯ (PNEUMONIA CROUPOSA). КРУПОЗНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ, ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ (PLEUROPNEUMONIA).** Возбудитель — пневмококк (диплококк Френкеля); изредка — диплобациллы Фридлендера и другие бактерии<sup>1</sup>. Инфекция проникает в легкие через дыхательные пути. Часто крупозная пневмония возникает непосредственно после резкого охлаждения

или промокания, что является предрасполагающей причиной, понижающей сопротивляемость организма, вследствие чего бактерии, постоянно обитающие в легочных путях, проникают в легочную ткань и вызывают заболевание.

**Симптомы и течение.** Болезнь начинается остро, сильным ознобом и быстрым повышением температуры до 39—40°. В течение 5—9, чаще 7 дней держится постоянная температура, которая критически (реже литически) падает до нормы. С первого же дня наступают явления общей интоксикации: общая слабость, разбитость, потеря аппетита, головная боль. Первыми признаками являются сухой кашель, боль при дыхании и кашле, учащенное дыхание. Лицо красное (гиперемировано), на губах и крыльях носа пузырьковое высыпание (herpes), язык обложен, сознание часто затемнено, бред. Ноздри при дыхании раздуваются. Через несколько дней появляется мокрота ржавого цвета. Перкуссия дает тупой или притупленный звук (поражена целая доля легкого). При аускультации — бронхиальное дыхание, крепитация и мелко-пузырчатые хрипы. Размеры сердца несколько увеличены, тоны глухие, артериальное давление понижено, пульс учащен (до 120 и больше ударов в минуту), слабого наполнения. При упадка

<sup>1</sup> Бсд. справочник



сердечной деятельности наблюдаются явления венозного застоя: посинение губ, пальцев рук и ног. В тяжелых случаях может наступить острая сосудистая недостаточность — коллапс, во время которого больные часто погибают. В крови отмечается значительный лейкоцитоз за счет увеличения плейтрофилов.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Надо отличать от очаговой пневмонии, туберкулеза и экссудативного плеврита.

**Лечение.** Специфическими средствами являются сульфаниламидные препараты (сульфидин, сульфазол, норсульфазол, сульф-азип, сульфадимезин и др.) и пенициллин.

Rp. Sulfidini 1,0 D. t. d. N.  
24 S. На курс лечения

#### П р и м е р н а я с х е м а л е ч е н и я

|           |       |        |                            |       |     |
|-----------|-------|--------|----------------------------|-------|-----|
| 1-е сутки | через | 4 часа | по 1,0 (первый прием 2,0), | всего | 7,0 |
| 2-е       | »     | »      | » 1,0                      | »     | 6,0 |
| 3-й       | »     | »      | 6 часов » 1,0              | »     | 4,0 |
| 4-е       | »     | »      | » 1,0                      | »     | 4,0 |
| 5-е       | »     | »      | 8 » » 1,0                  | »     | 3,0 |

В с е г о . . . 24,0

Из указанных препаратов сульфидин наиболее токсичен. В настоящее время предпочитают менее токсичные сульфаниламидные препараты, не уступающие по своему действию сульфидину (сульфазол, норсульфазол, сульфазин, сульфадимезин и др.). Применяют их по той же схеме, но их можно давать в большей дозировке: первые 2—3 дня по 1,5 каждые четыре часа (до 10 г в сутки), затем 2 дня — по 1,0 через 4 часа и 2 дня — по 1,0 через 6 часов. Сульфадимезин дают в течение 3 суток по 1,0 через 6 часов, а затем по 0,5 2—3 раза в день до полного выздоровления.

Каждый порошок сульфаниламидных препаратов нужно обязательно запивать большим количеством жидкости, лучше всего щелочной (полстакана боржома или содового раствора — чайную ложку соды на стакан воды).

Сульфаниламиды могут вызывать интоксикацию: потерю аппетита, тошноту, рвоту, головные боли и др. Иногда развивается лейкопения, вплоть до агранулоцитоза (см.), дизурические явления, происходит уменьшение выделения мочи. При заметной интоксикации сульфаниламидные препараты отменяют и переходят на курс лечения пенициллином.

Пенициллин вводят внутримышечно по 50000—100 000 единиц каждые 3—4 часа в течение 3—4 дней. Он особенно показан в случаях, когда сульфаниламидные препараты не оказывают действия (устойчивые формы пневмококков по отношению к сульфаниламидным препаратам) (см. *Абсцесс легкого*). Иногда хороший эффект получается при одновременном применении сульфаниламидных препаратов и пенициллина.

Громадную роль играет внимательный и правильный уход: постельный режим, несколько приподнятое Положение для облегчения

одышки, соблюдение полного покоя; частое проветривание помещения. Согревающий компресс, банки, горчичники на грудную клетку, обильное питье, лимонная вода, клюквенный морс, чай, кофе, молоко. Если больной пьет мало, особенно при приемах сульфаниламидных препаратов, то вливают под кожу физиологический раствор поваренной соли или рингеровский раствор или ставят из них капельные клизмы.

Пр. Sol. Natrii chlorali physiologicae (0,85%) 000,0  
Sterilisetur! DS. Для подкожного вливания

Пр. Natrii chlorati 9,0 Kali i  
chlorati  
Calcii chlorati  
Natrii bicarbonici aa 0,2  
Aq. destill. 1 000,0  
Sterilisetur!  
MDS. Рингеровский раствор для подкожного вливания

Пищу давать жидкую, полужидкую и питательную (высококалорийную в протертом виде). Кормить часто .. малыми порциями.

При болях, сильном кашле и одышке — наркотические средства (морфин, кодеин и др.). Для лучшего отделения мокроты — отхаркивающие (ипекакуана, термописис) или сочетание наркотических с отхаркивающими (см. *Абсцесс легкого*). Главное внимание обращается на состояние сердечно-сосудистой системы: тщательно следить за пульсом; внутрь или под кожу — камфора, кофеин, стрихнин, коразол.

Пр. 01. campborati 20% 2,0 D. t. d. N. 12 in amp. S.  
По 2 мл 3—6 раз в сутки подкожно

Пр. Sol. Coffeini natrio-benzoici 20% 1,0 D. t. d. N. 10 in amp. S. По 1 мл под кожу 3 раза в день

Пр. Sol. Corazoli 10% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл под кожу 3 раза в день

Пр. Sol. Strychnini nitrici 0,1% 1,0 D. t. d. N. 0 in amp. S. 1 мл под кожу 2—3 раза в день

Пр. Camphorae tritac 0,2 D. t. d. N. 0  
S. По 1 порошок 3 раза в день

Rp. Camphorae tritac 2,0  
T-raa Yalerianae aethercae 20,0 S;  
Через 3 часа по 20 капель

Rp. Coffeini natiio-salicyliei 0,2 D. t. d. N.  
10 S. По 1 порошку 3 раза в день

Также назначают наперстянку (Digitalis).

Up. Inf. fol. Digitalis ex 1,0 : 200,0  
DS. Через 3 часа по 1 столовой ложке

Для улучшения питания и кровообращения в сердечной мышце — внутривенное вливание глюкозы.

Rp. Sol. Cxhicosi 40% 20,0 Sterilisetur! DS.  
Для внутривенного вливания

При резком падении артериального давления впрыскивают адреналин.

Pr. Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% 1,0 D. t. d.  
N. 6 in amp. S. По 1 ампуле под кожу

При цианозе — кровопускание (100—400 мл) и кислород. При возбуждении, бессоннице — снотворные и успокаивающие (бромистые препараты).

Rp. Bromurali 0,3 D. t. d. N. 3 S.  
1 порошок на ночь

Rp. Luminali 0,05  
D. t. d. N. 6 in tabu!.  
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp. Veronal! 0,5 D.  
t. d. N. 2  
S. За час до сна 1 порошок в полустакпе горячей воды.

При высокой температуре, головной боли и бреде — лед на голову. Протирать кожу, очищать язык и слизистую рта. Наблюдать за отпавлением кишечника и мочеотделением. Особенно тщательно следить за состоянием пульса.

**ПНЕВМОНИЯ ОЧАГОВАЯ (PNEUMONIA LOBULARIS). БРОНХОПНЕВМОНИЯ (BRONCHOPNEUMONIA). КАТАРРАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ (PNEUMONIA CATARRHALIS).** При очаговой пневмонии поражаются отдельные легочные доли (очаги). Возбудитель — гриппозный вирус, пневмококки, пневмобациллы, стафилококки, стрептококки. Как осложнение (вторичная инфекция) очаговая пневмония часто развивается при различных инфекционных болезнях: кори, скарлатине, сепсисе, брюшном тифе и др. Она может возникнуть от попадания в легкие посторонних веществ (слизи, воды, пищи, крови, рвотных масс), особенно во время бессознательного состояния (апоплексии, общего наркоза и пр.). Такая пневмония называется аспирационной (вдыхательной). Простуда

предрасполагает к возникновению очаговой пневмонии. Очаговую пневмонию называют также бронхопневмонией, так как она часто присоединяется к острому бронхиту. Воспалительный процесс с мелких бронхов переходит на легочные альвеолы — доли.

**Симптомы и течение.** Температура до 39—40°, кашель со слизистой, гнойной или слизисто-фибринозной мокротой, часто одышка. Болезнь часто начинается насморком, кашлем, недомоганием; температура повышается в течение нескольких дней. При перкуссии небольшие очаги притупления (если воспалительный процесс порастил группы легочных долек). На месте притупления выслушивается крепитация и бронхиальное дыхание, влажные и сухие хрипы. В тяжелых случаях отмечается интоксикация сердечно-сосудистой системы: глухие тоны сердца, учащение и ослабление пульса, одышка. Кроме того, наблюдается потеря аппетита, головная боль, плохой сон, общая слабость.

При пневмонии, вызванной гриппозным возбудителем (вирусом), наблюдаются часто и общие гриппозные явления: насморк, общая разбитость, головная боль, ломота всего тела и боль в глотке.

Болезнь тянется 2—4 недели; улучшение наступает постепенно, сопровождаясь медленным падением температуры. Наиболее тяжело она протекает у маленьких детей, стариков и ослабленных, истощенных больных. Воспалительный процесс может захватить новые участки легких (пневмония принимает ползучий характер). Такие пневмонии тянутся 1—2 месяца и часто заканчиваются смертью.

**Распознавание.** Очаговую пневмонию следует отличать от бронхита, крупозного воспаления легких, туберкулеза легких, плеврита и абсцесса легких.

**Лечение.** Лечение и уход <sup>с</sup> основным те же что и при крупозной пневмонии. Лучшее средство — сульфаниламидные препараты и пенициллин (см. *Пневмония крупозная*).

**ПНЕВМОСКЛЕРОЗ.** Пневмосклерозом называется разрастание соединительной (фиброзной) ткани в легких, ведущее к рубцеванию (склерозу) различных участков легких. Обычно пневмосклероз является конечной стадией различных легочных заболеваний. Часто повторяющиеся пневмонии, абсцессы легких, хронические бронхиты, бронхоэктазы, пневмоконнозы ведут к развитию пневмосклероза. Хронические воспалительные процессы в межтканевой ткани легких (хронические пневмонии) приводят к пневмосклерозу.

**Симптомы и течение.** Симптомы: кашель, чаще с мокротой, одышка. Перкуторно: корббочный звук с отдельными участками притупления. Сухие и влажные хрипы. Явления легочной и сердечной недостаточности (легочное сердце).

Болезнь хроническая, постепенно прогрессирующая, если не устранена вызвавшая ее причина.

**Распознавание.** Нужно отличать от хронического туберкулезного процесса в легких, особенно при наличии лихорадки (хронические пневмонии). Анамнез, исследования мокроты, рентгеноскопия помогают уточнить диагноз.

**Лечение** основного заболевания, вызвавшего склеротические изменения в легких. Климатическое лечение, физиотерапия, лечеб-

пая физкультура, перемена работы. Симптоматическое лечение. Лечение сердечной недостаточности (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая*).

**ПНЕВМОТОРАКС. СКОПЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ПОЛОСТИ ПЛЕВРЫ (PNEUMOTHORAX).** Пневмоторакс бывает искусственным, когда с лечебной целью (главным образом при туберкулезе легких) вдувают в полость плевры воздух, и естественным, или самопро-извольным, когда в результате разрыва или некроза легочной ткани образуется сообщение между бронхом и полостью плевры. Причины самопроизвольного (спонтанного) пневмоторакса: туберкулез, абсцесс или гангрена легких, бронхоэктазы, травмы и ранения легких.

**Симптомы и течение.** Внезапно появляется резкая боль в груди, сильная одышка, упадок сердечной деятельности (учащенный слабый пульс, цианоз). При перкуссии — коробочный звук с тимпаническим оттенком и смещение сердца в здоровую сторону, при аускультации — ослабленное дыхание.

Если в полость плевры не попадает инфекция, воздух может постепенно рассосаться, и наступает выздоровление. Чаще развивается серозный плеврит, а при попадании гноеродных бактерий к плевмотораксу присоединяется гнойный плеврит (пиопневмоторакс). Тогда появляются признаки наличия воздуха в полости плевры и вынотного плеврита: внизу легкого тупой звук, а выше тупости — коробочный и тимпанический. Наличие воздуха позволяет жидкости свободно перемещаться при перемене положения больного; при встряхивании больного слышен шум плеска.

**Лечение.** Полный покой, приподнятое положение в постели. При резкой одышке — морфин или омнопон под кожу. При сердечной недостаточности под кожу камфора, кофеин, стрихнин. При пиопневмотораксе — хирургическое лечение.

**ПОДАГРА (PODAGRA). АРТРИТ МОЧЕКИСЛЫЙ (ARTHRITIS URICA).** Вследствие нарушения белкового обмена в тканях и крови скапливается большое количество мочевой кислоты и ее солей, которые при недостаточном выделении почками отлагаются в суставных хрящах и шашечных сухожилиях.

**Симптомы и течение.** В большинстве случаев подагра развивается постепенно. Чаще поражаются мелкие суставы, в особенности пальцев рук и ног, а затем крупные: голеностопные, коленные, локтевые. Пораженные суставы болезненны при движении и давлении, немного отекают. С течением времени, вследствие отложения солей, они обезображиваются, их подвижность ограничивается, появляются утолщения (tori). Иногда подагра проявляется в виде острых приступов резкой боли в каком-либо суставе (обычно мелком), часто в большом пальце ног. Течение хроническое с временными улучшениями при соблюдении режима и лечения.

**Распознавание и лечение.** Нужно дифференцировать с хроническим ревматизмом и вообще суставными заболеваниями (артритами).

**Лечение.** В основном лечение диетическое. Запрещаются спирт, напитки, всякие острые, кислые продукты и приправы. Диета молочно-растительная: молочные продукты, яйца, хлеб, крупа, овощи, фрукты, ягоды. Мясо (рыба) ограничено и только

в вареном виде. Ограничиваются и растительные продукты, богатые белком (горох, фасоль, бобы, чечевица, грибы).

Для выделения из организма мочевой кислоты принимают щелочные минеральные воды (боржом, эссенуки и др.), атофан (по 0,5 3 раза в день), уротропин, литий (Lithium salicylicum по 0,5 3 раза в день).

Вр. Urotropini 0,5 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3 раза в день

Ввиду токсичности атофана его следует давать периодически. После курса лечения в 20 порошков по 0,5 делают перерыв в 2—4 недели.

Назначают также йодистые препараты.

Rp. Sol. Kalii iodati ex 6,0:200,0 DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Хорошие результаты наблюдаются от физических методов лечения: теплых соленных ванн, грязевых, радоновых, сероводородных, местных ванн (четырёхкамерных). Показаны к: рорты: Пятигорск, Саки, Евпатория (грязелечение), Мацеста (сероводородные ванны), Цхалтубо (радоновые ванны), Одесса (соленные ванны).

**ПОЛИАРТРИТ ОБЕЗОБРАЖИВАЮЩИЙ, ДЕФОРМИРУЮЩИЙ (POLYARTHRITIS DEFORMANS).** Причины: нарушения обмена и функций эндокринных желез, инфекции и простуда.

**Симптомы и течение.** Обычно поражаются 1—2 крупных сустава, но в процесс могут вовлекаться и мелкие суставы, например, пальцев рук и ног. Суставы отекают, появляется боль, ограничение подвижности, хруст при движении. Постепенно происходят изменения в хрящах суставных поверхностей и суставных концов костей, утолщение синовиальной оболочки и разрастание околосуставной ткани. Суставы увеличиваются в объеме, нарушается их подвижность, происходит стягивание их при обезображивании. Болезнь длится годами. ■

**Лечение** главным образом физиотерапевтическое: грязе лечение, сероводородные и соленные ванны, диатермия, светолечение, массаж. В остальном лечение симптоматическое и общеукрепляющее. \*

**ПОЛИАРТРИТ РЕВМАТИЧЕСКИЙ ОСТРЫЙ (POLYARTHRITIS RHEUMATICA ACUTA).** Ревматизм — инфекционная болезнь, возбудитель которой точно не известен. Из возбудителей чаще всего находят гемолитического стрептококка. Кроме инфекции, для появления ревматизма необходима сенсibilизация организма, т. е. повышение его чувствительности к аллергенам, которыми могут быть бактерии и их токсины. Инфекция чаще обнаруживается в миндалинах, так как ревматизму обычно предшествует ангина, в кариозных зубах и в других инфицированных очагах.

В возникновении ревматизма главную роль играет не какой-либо возбудитель, а измененная реактивность всего организма, вы-

званная в первую очередь нарушениями в деятельности центральной нервной системы.

Сырость и холод<sup>1</sup> предрасполагают к заболеванию ревматизмом. Ревматический процесс поражает сердце и в большинстве случаев одновременно и суставы (см. *Миокардит*, *Ревмокардит*, *Перикардит*, *Эндокардит*).

**Симптомы и течение.** Резкая боль, припухлость и покраснение пораженных суставов. Болезнь начинается обыкновенно с заболевания 1—2 суставов, но могут поражаться все остальные суставы. Большей частью поражаются крупные суставы: плечевые, коленные, голеностопные, лучезапястные и локтевые (тазобедренные редко). Характерна «летучесть» в поражении суставов, т. е. появление воспалительного процесса все в новых суставах и затихание или прекращение воспаления в ранее пораженных суставах. Температура при остром ревматизме обычно ремиттирующего характера. Болезнь продолжается в среднем 1—2 месяца, иногда и дольше. Обычно отек и боль проходят, подвижность в суставах возвращается к норме. Одновременно с суставами ревматический процесс захватывает и сердце: появляются ревматический эндокардит и миокардит (ревмокардит), а иногда и перикардит.

**Распознавание.** Острый суставной ревматизм нужно отличать от различных инфекционных артритов и от артритов другой этиологии. Ведущие признаки: «летучесть» процесса, одновременное поражение сердца, успешность лечения салициловыми препаратами и обычно полное восстановление суставов после ревматического приступа. После ревмокардита обычно остается порок сердца.

**Лечение.** Салициловые препараты: салициловый натрий (по 1,0 0—8 раз в день), аспирин (по 1,0 6 раз в день), пирамидон (по 0,5 Г) 4 раза в день).

Постельный режим с наиболее удобным положением в кровати. На больные суставы кладут согревающие компрессы или обертывают их марлей, смазанной салициловой или метилсалициловой мазью.

Rp. Ung. acidi salicylici 30,0 DS.

Мазь

Rp. Methyl salicylici 10,0  
Vasellini 40,0 M. f. ung. DS.

Мазь

Для внутривенного введения весьма пригоден салитропин.

Rp. Sol. Urotropini 40% 25,0 Natrii salicylici 4,0 Coffeini  
natrio-salicylici 1,0 Sterilise tur! DS. По 4—6—10 мл  
внутривенно 1 раз в день

Поражение сердца требует соответствующих мероприятий (см. *Миокардит*, *Эндокардит*, *Перикардит* и *Пороки сердца*).

**Профилактика.** Предохранять организм от рецидивов. Удалять инфекционный очаг (миндалины, кариозные зубы и др.); ограждать больного от простуды (холода, сырости).

**ПОЛИАРТРИТ РЕВМАТИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ (POLYARTHRITIS RHEUMATICA CHRONICA).** Хронический ревматизм часто является следствием острого. Сырой климат, сырое и холодное жилище или рабочее помещение способствуют переходу острого процесса в хронический.

**Симптомы и течение.** После острого приступа (атаки) ревматизма припухлость и болезненность в суставах могут остаться, особенно после повторных ревматических атак (рецидивов). Часто эти болезненные явления обостряются. Боли учащаются, особенно при неблагоприятной погоде (при ее переменах). В суставах появляется хруст, они утолщаются и постепенно деформируются.

**Лечение.** Во время обострений применяют салициловые препараты. Главными методами лечения являются различные физиотерапевтические процедуры: грязелечение, сероводородные и солевые ванны, светолечение, массаж.

**ПОЛИАРТРИТЫ ИНФЕКЦИОННЫЕ (POLYARTHRITIS INFECTIONOSA).**

При различных инфекциях наблюдаются соответствующие артриты: туберкулезные, гонорройные, сифилитические, дизентерийные, бруцеллезные и др.

Иногда инфекционные полиартриты бывают неясной этиологии, обычно гнойной, при наличии гнойных очагов (хронические тонзиллиты, поражения зубов, придаточных полостей и пр.).

**Симптомы и течение.** При инфекционных артритях поражаются 1—2 сустава, множественное заболевание их наблюдается редко. В суставах происходят стойкие анатомические изменения, нарушение их функций, а иногда анкилоз. Часто суставы утолщаются, изменяют свою форму, и подвижность их значительно ограничивается. Такие резкие изменения наблюдаются, например, при гонорройных или туберкулезных артритях, которые часто заканчиваются полным анкилозом. Симптомы в течение во многом зависят от течения основного заболевания. При инфекционных полиартритах нелепой этиологии часто наблюдается множественное поражение суставов, так же как при ревматизме.

**Распознавание.** Не представляет затруднений при инфекционных артритях определенной этиологии, при поясной этиологии оно довольно трудно, так как клиническая картина во многом сходна с ревматическим полиартритом. При инфекционном полиартрите не поражается сердце, не наблюдается «летучести» процесса (воспаление не переходит с одного сустава на другой), салициловые препараты не оказывают такого эффективного действия и в суставах остаются морфологические изменения.

**Лечение.** Связано с лечением основного заболевания. Сифилитические артриты лечатся специфическими средствами (поваренная соль, ртуть, биохинин, йод). При гонорройных артритях хорошее действие оказывают подкожные впрыскивания гонококковой вакцины. При гонорройных, а также септических полиартритах—сульфаниламидные препараты, пенициллин. При туберкулезных артритях—

тах — продолжительный покой (вытяжение, наложение гипсовой повязки), а также общеукрепляющее лечение. При лечении инфекционных (стрептококковых, стафилококковых и др.) артритов нужно раньше всего удалить гнойный очаг (миндалины, кариозные зубы и пр.); затем их лечат сульфаниламидными препаратами, в некоторых случаях хорошее действие оказывает пенициллинотерапия (Ш 000—600 000 единиц в сутки).

**ПОНОСЫ (DIARRHOEA).** Болезненное состояние, при котором наблюдается жидкий стул. Поносы возникают при усиленной кишечной перистальтике и при совершенно здоровой стенке кишок на нервной почве или в зависимости от качества пищи. Грубая растительная пища, дающая много непереваренных остатков (овощи и фрукты, особенно их кожура, хлеб с отрубями), лекарственные вещества (слабительные), уменьшение или совершенное прекращение всасывания жидкого содержимого стопкой кишечника, выделение слизистой оболочкой в просвет кишечника трансудата или экссудата, венозный застой в стенках желудочно-кишечного тракта — все это может вызвать понос. Чаще же всего покосы бывают при желудочно-кишечных заболеваниях.

**Симптомы и течение.** При энтеритах ввиду усиления процессов брожения в тонких кишках возникают бродильные поносы (бродильная диспепсия), урчание, пенные светлые испражнения с обычным запахом кислой реакции. При колитах обычно наблюдаются гнилостные поносы (гнилостная диспепсия) вследствие усиления гнилостных процессов в толстых кишках, вздутие живота, испражнения более темного цвета с резким вонючим запахом (сероводород), щелочной реакции. Течение в значительной степени зависит от причинной болезни и течения основного заболевания.

**Лечение.** При бродильной диспепсии нужно ограничивать углеводистую пищу и назначать преимущественно белковую: бульоны (уха), творог, яйца и мясо или рыба. При гнилостной — запретить белковую пищу (особенно животные белки) и назначать углеводистую: сахар, овощи, фрукты, кашп. Лечение поносов при тех шпг других заболеваниях см. *Гастроэнтероколит острый, Колит острый. Энтерит острый*, глава II. *Инфекционные болезни: брюшной тиф и, паратифы, Дизентерия, холера.*

**ПОРОКИ СЕРДЦА (VITIIUM CORDIS).** Различают врожденные пороки и приобретенные пороки. Врожденные пороки встречаются очень редко, по обычно такие больные погибают еще в раннем детстве. Причины приобретенных пороков: чаще всего ревматизм (ревматический эндокардит); затем септический эндокардит, сифилитическое поражение клапанов и склеротические изменения в них. При пороках наблюдается недостаточность клапанов или сужение отверстий между различными отделами сердца.

Наиболее часто встречается недостаточность митрального клапана, сужение отверстия между левым предсердием и желудочком, недостаточность аортальных клапанов и стеноз (сужение) аортального отверстия.

При митральной недостаточности во время систолы часть крови поступает обратно в левое предсердие, в которое в свою очередь притекает кровь из легких. Во время диастолы вся масса кропи

из предсердия поступает в левый желудочек. От увеличенного количества крови полости левого предсердия и желудочка расширяются. Выбрасывание большого количества крови вызывает гипертрофию мышц левого предсердия и желудочка. Мышца правого желудочка, вынужденная преодолевать застой крови в легких, также гипертрофируется. Благодаря расширению и гипертрофии сердце может настолько приспособиться к новым условиям работы, что с каждой систолой будет выбрасывать в аорту нормальное количество крови. Такое состояние сердца, когда оно вполне справляется со своей работой, называется компенсацией, а порок сердца — компенсированным.

При сужении митрального отверстия происходит расширение и гипертрофия левого предсердия и гипертрофия правого желудочка. При недостаточности аортальных клапанов во время диастолы в левый желудочек поступает кровь одновременно из левого предсердия и обратно из аорты. Поэтому происходит расширение и гипертрофия левого желудочка. С систолой в аорту поступает увеличенное количество крови, а с каждой диастолой при компенсированном пороке обратно в желудочек возвращается только излишек крови; таким образом, организм получает нормальное количество крови. При сужении аортального отверстия левый желудочек усиленно работает, чтобы протолкнуть кровь через суженное отверстие, вследствие чего наблюдается его гипертрофия, а ш: -игда и расширение.

**Симптомы и течение.** При перкуссии границы различных отделов сердца увеличены: при недостаточности митрального клапана — увеличение влево, вправо и вверх; при сужении митрального отверстия — вправо и вверх; при аортальных пороках — влево и вниз (особенно при недостаточности клапанов). При аускультации отмечаются сердечные шумы: при недостаточности митрального клапана — систолический шум у верхушки, при стенозе митрального отверстия — диастолический (пресистолический); при митральных пороках — усиление второго тона (акцент) над легочной артерией (во втором межреберье слева, около грудины). Иногда при митральном стенозе над легочной артерией вместо одного второго тона выслушивается два тона (раздвоение второго тона); при митральном же стенозе на верхушке можно выслушать иногда усиленный (хлопающий) первый тон. При недостаточности аортальных клапанов выслушивается диастолический шум у основания сердца (во втором межреберье справа, около грудины), при стенозе — систолический. Пульс при недостаточности митрального клапана может быть нормального наполнения и напряжения, при стенозах — слабого Заполнения, при аортальной недостаточности — полный с быстрым подъемом пульсовой волны и быстрым ее падением (скорый пульс).

В случае сердечной компенсации больного часто ничто не беспокоит, и обнаружить порок можно только путем объективного исследования сердца. При ослабления сердечной мышцы появляются симптомы расстройства сердечной компенсации: при митральных пороках наблюдается преимущественно недостаточность правого желудочка, а при аортальных — левого (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность тропическая*).

Течение болезни зависит от размеров поражения клапана, сносебности сердечной мышцы компенсировать порок и от соблюдаемого режима.

**Р а о п о з н а л а и с** главным образом на основаниш выслушиваемых шумов; различные пороки отличают друг от друга по характеру шума (систолический или диастолический) и по месту их выслушивания. Определение границ сердца, а также рентгенологическое исследование имеют большое значение в диагностике различных пороков сердца.

**Л е ч е н и е.** При компенсированном пороке не требуется особого лечения; необходимо лишь соблюдать режим, щадающий сердечную мышцу: больной не должен заниматься чрезмерным физическим трудом, не переутомляться; необходимо ограничить питье, быть умеренным в еде, наблюдать за правильным действием кишечника; нельзя употреблять спиртных напитков и курить; занятия легким спортом могут быть полезны, так как они упражняют, тренируют сердечную мышцу. Когда наступают явления сердечной декомпенсации, ее нужно лечить, как любую сердечную недостаточность (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая*).

**ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА** см. *Почечнокаменная болезнь*.

**ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКИ ВОСПЛЕНИЕ** см. *Пиэлл*.

**ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (NEPHROLITHIASIS).** В образовании почечных камней играет роль нарушение обмена веществ. Образованию камней способствует питьевая вода, богатая кальциевыми солями; нарушение кальциевого и фосфорного обмена, воспаление мочевых путей, застой мочи. Камни образуются из мочевых солей (мочекислых, щавелевокислых, фосфатов), преимущественно в почечной лоханке. Осаждению солей способствуют продукты воспаления слизистых оболочек почечной лоханки (пиэлитов): комочки слизи, гноя, спущенный эпителий, сгустки крови. Недостаток витамина А может способствовать образованию камней, так как при этом гиповитаминозе в большом количестве слушивается эпителий мочевых путей. Нарушение регулирующей роли нервной системы имеет большое значение в возникновении почечных камней.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Основной симптом — приступы резких болей в области почки (почечная колика). Приступы наступают внезапно, боли отдают в пах и половые органы, появляется озноб, часто рвота, холодный пот, слабый пульс. На больной стороне отмечается положительный симптом Пастернацкого. Мочеиспускание частое и болезненное. В моче появляется кровь. Течение болезни зависит от величины камня, болезненных и воспалительных явлений, вызываемых камнем, а также от правильности лечения.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Нужно дифференцировать с заболеваниями органов живота, сопровождающимися приступами болей (печеночной, язвенной болезнью, аппендицитом), а также с некоторыми почечными заболеваниями (очаговый нефрит, пиелит).

**Л е ч е н и е.** Полный покой, грелки, припарки, теплые ванны. Под кожу вводят морфин или омиопон, а также атропин, питье

в большом количестве минеральных вод (щелочные только при мочекислой реакции), молочно-растительная диета. Больниц камни, а также камни, вызывающие частые приступы почечной колики и гнойное воспаление мочевыводящих путей, удаляют хирургическим путем. Пиелит и цистит лечат обычным путем (/м.).

**ПОЧКА ОПУЩЕННАЯ. БЛУЖДАЮЩАЯ ИЛИ ПОДВИЖНАЯ ПОЧКА (NEPHROPTOSIS. REN MOBILIS).** Подвижная, в то же время опущенная (преимущественно правая) почка чаще встречается у женщин, особенно многогравидных, у которых ослаблены мышцы живота и наблюдается общее опущение брюшных органов. Резкое похужение, ушибы, прыжки способствуют опущению почки.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Тяжесть в яшвоте, боли в полепце, усиливающиеся при ходьбе и тяжелой работе. При пальпации живота прощупывается подвижная почка (основной симптом болезни). Иногда болезнь протекает бессимптомно.

**Л е ч о в и е.** Ношение бандажа. Запрещение тяжелой физической работы и занятий спортом; усиленное питание истощенных больных. При резких болях — постельный режим, грелки, теплив ванны и даже инъекции морфина или опиопа.

**ПОЧКА СУЛЕМОВАЯ** см. *Нскронефроз*.

**ПРОСТРЕЛ** см. *Миозиты и миалгии*.

**ПУЛЬС.** Нормально у взрослого человека частота пульса равняется 70—80 ударам в минуту. Во время сна пульс может доходить до 50 ударов в минуту. У старых людей пульс обычно более редкий. Учащение пульса бывает в детском возрасте: у новорожденных — 140 ударов в минуту, до года — 130-110, до 5 лет — 110—100 ударов в минуту и т. д. При повышении температуры на один градус пульс обычно учащается на 10—15 ударов в минуту. Учащение пульса бывает при физическом напряжении, нервном возбуждении, при гипертиреозе (базедовой болезни), при сердечной и сосудистой недостаточности (миокардиты, коллапс, декомпенсированные пороки сердца, инфаркт миокарда и др.). Иногда сердечные сокращения бывают настолько слабы, что пульсовая волна не доходит до лучевой артерии. Разница между количеством сердечных сокращений и числом ударов пульса называется дефицитом пульса (мерцательная аритмия, декомпенсация сердца).

Важно знать не только частоту пульса, но также полноту, напряжение, скорость, пульса и его правильность. Если мышца сердца здоровая, получается сильная пульсовая волна. Такой пульс называется полным\*. Если нужно употребить довольно значительное усиление, чтобы прекратить дупльсацню артерии, пульс называется напряженным. Он наблюдается при повышенном артериальном давлении. При понижении артериального давления напряжение стенок артерий незначительно, и уже при слабом надавливании на артерию пульс исчезает. Такой пульс называется мягким. ■

При ослаблении сердечной деятельности и низком артериальном давлении пульс иногда едва прощупывается; такой пульс называется нитевидным. В некоторых случаях сердечные сокращения бывают настолько слабы, что пульс совершенно не ощущается.

Скорым называется пульс с быстрым подъемом пульсовой волны и таким, же быстрым ее падением. При исследовании пульса июлу-

чается ощущение более сильного удара кровяной волны в копчики пальцев и пезкого ее спадения. Скорость пульса не нужно смешивать с частотой, т. е. с количеством ударов в минуту.

При достаточно высоком пульсе и в то же время при слабом напряжении стенки артерии, вследствие расслабления тонуса, за пульсовой волной ощущается вторая меньшая волна. Такой пульс называется дикротическим. Он чаще наблюдается при инфекционных заболеваниях, например, при брюшном тифе, крупозном воспалении легких и др.

При исследовании пульса нужно обращать внимание на состояние стенок артерии. С напряженным пульсом не следует смешивать патологическое изменение стенки сосудов. При атеросклерозе происходит уплотнение Стенки сосудов. Артерия становится плотной, трудно сжимаемой, «катается» под пальцами, как шпур, причем получается впечатление значительного напряжения стенки сосуда.

Иногда отмечается разность наполнения пульса на руках: на одной руке полный пульс, а на другой — малый. Это зависит от врожденных аномалий артерий или различных патологических процессов (сдавление артерий опухолью, увеличенными лимфатическими узлами и пр.).

Важно следить за равномерностью пульса. Если удары пульса следуют неравномерно один за другим, пульс называется неправильным, или аритмичным (см. *Аритмии*).

**РАК ЖЕЛУДКА** см. гл. VI. *Хирургические болезни*.

**РАК ДРУГИХ ОРГАНОВ** см. гл. VI. *Хирургические болезни*.

**РАСШИРЕНИЕ ЖЕЛУДКА (DILATATIO VENTRICULI).** Причинами являются ослабление тонуса мышечной стенки желудка (атония) вследствие врожденной слабости мышечной оболочки, общего истощения организма, чрезмерного переедания и употребления большого количества жидкости, сужение привратника рубцовой тканью или опухолью. При расширении желудка обыкновенно наблюдается и его опущение (см. *Гастроптоз*). Вследствие ослабления мускулатуры желудка двигательная функция его понижена, а потому пища застаивается по нескольку дней, разлагается и загнивает.

**С и м т о м ы.** Плохой запах изо рта, тухлая отрыжка, периодическая рвота большими массами с резким запахом. Обычно в таких случаях присоединяется хронический гастрит.

**Л е ч е н и е.** Пищу и питье давать часто, небольшими порциями. При заставании пищи утром натошак выкачивают зондом содержимое желудка и промывают его. При значительном сужении привратника показана операция (гастроэнтеростомия). Бандаж. В остальном лечение то же, что и при хроническом гастрите (см.).

**РВОТА (VOMITUS).** Рвота бывает центральной происхождения и рефлекторная. Рвота происходит от раздражения рвотного центра (непосредственно или по рефлексу, исходящему из желудка, печени, почек, брюшины, яичников и других органов). Рефлекторная рвота наблюдается при различных желудочных (гастрит язвенная болезнь, рак) и кишечных заболеваниях (аппендицит)

кишечная непроходимость), воспалении брюшины, яичников, печеночной и почечной коликах и др. Центральная (мозговая), в том числе и коркового происхождения, рвота бывает при сотрясении мозга, при раздражении рвотного центра различными токсинами, циркулирующими в крови (при уремии, скарлатине, менингите, головных болях различного происхождения и пр.). Рвота беременных происходит, по всей вероятности, вследствие нарушения функций эндокринных желез и под влиянием нервных факторов.

Надо тщательно расспросить больного и обследовать его, чтобы выяснить происхождение рвоты.

Для правильной диагностики очень важно осмотреть рвотные массы. Они часто состоят из только что съеденной пищи или нищи, принятой за несколько часов, иногда за сутки и более до рвоты в недостаточно или совсем непереваренной. При желудочном кровотечении рвота красного цвета, при раке (при распаде раковой опухоли) — цвета кофейной гущи, при забрасывании желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок — желто-зеленого цвета; при пустом желудке иногда больного рвет одной желчью. Рвотные массы кислого запаха, если в желудке много кислот, тухлого — если в желудке происходят процессы гниения; при уремии рвотные массы пахнут мочой, при непроходимости кишок может быть каловая рвота.

Во время рвоты наступает общая слабость, и обледнение лица, похолодание конечностей; выступает «холодный» пот, пульс частый, малого наполнения, кровяное давление падает.

После прекращения рвоты больного нужно уложить, дать прополоскать рот, вытереть губы, в случае надобности положить к конечностям грелки, при упадке сердечной деятельности — кофеин, камфора под кожу. Если рвота была следствием какого-либо тяжелого заболевания, то принимаются соответствующие меры.

**РВОТА КРОВАВАЯ** см. *Кровотечение желудочно-кишечное*.

**РЕВМАТИЗМ** см. *Полиартрит ревматический. Ревмокардит*.

**РЕВМАТИЧЕСКИЙ ОСТРЫЙ ПОЛИАРТРИТ** см. *Полиартрит ревматический острый*.

**РЕВМАТИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ПОЛИАРТРИТ** см. *Полиартрит ревматический хронический*.

**РЕВМОКАРДИТ (RHEUMOCARDITIS)** — ревматическое поражение сердца, причем воспалительный процесс может одновременно поражать эндокард, миокард и перикард (см. *Миокардит острый, Перикардит и Эндокардит*).

**САХАРНАЯ БОЛЕЗНЬ** см. *Диабет сахарный*.

**САХАРНОЕ МОЧЕИЗЛУЧЕНИЕ** см. *Диабет сахарный*.

**СЕРДЕЧНАЯ АСТМА** см. *Астма сердечная*.

**СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОСТРАЯ, КОЛЛАПС, ШОК, ОБМОРОК.** Острая сердечная недостаточность может наступить при острых сердечных заболеваниях (острый миокардит, экссудативный перикардит, инфаркт миокарда и др.) к острым инфекциях (например, крупозное воспаление легких); у здорового человека при утомительном физическом перенапряжении (например, при беге на дальнюю дистанцию, особенно без соответствующей тренировки). Острая сосудистая недостаточность возни-

кает от уменьшения притока крови к сердцу вследствие ослабления тонуса артерий, а также спадения вен, в результате чего резко уменьшается поступление крови в сердце. К о л л а п с — острая сосудистая недостаточность, наступающая при обильных кровотечениях (наружных и внутренних), при острых инфекциях и интоксикациях, а шок — острая сосудистая недостаточность (коллапс), появляющаяся при переломах, ранениях, остром перитоните и т. п. в связи с резкой болью или психической травмой (см. гл. VI. *Хирургические болезни*).

Вследствие недостаточности кровоснабжения мозга (обильное кровотечение, спазм мозговых сосудов) может наступить обморок (потеря сознания). Обморок часто наступает при психических переживаниях, сильной боли, вследствие пребывания длительное время в жарком, душном помещении. Следовательно, резкие раздражения коры головного мозга могут вызвать шок (коллапс), а также обморок.

Часто наблюдается одновременно сердечная и сосудистая недостаточность. Так, при значительных кровопотерях вслед за сосудистой недостаточностью наступает и сердечная.

При инфаркте миокарда, при острых инфекционных болезнях (тифах, крупозном воспалении легких в нр.) наблюдается сердечно-сосудистая недостаточность.

**Симптомы и течение.** Первый признак сердечной недостаточности — резкая одышка, вследствие которой больной принужден сидеть; сердечная астма и отек легких появляются при преимущественном ослаблении левого желудочка, а цианоз — при недостаточности главным образом правого желудочка. Артериальное давление падает, пульс становится слабым, учащенным и часто неправильным. При коллапсе, шоке — общее ослабление организма, малый, едва прощупываемый (нитевидный) пульс или даже полное его отсутствие, частое, поверхностное дыхание, бледность кожных покровов, похолодание конечностей, холодный пот, головокружение, иногда затемненное сознание.

При обмороке наблюдается головокружение, потеря сознания, бледность покровов, ослабление пульса (см. гл. XVI. *Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях*).

**Лечение.** При сердечной недостаточности полный покой, приподнятое удобное, положение больного, чистый, свежий воздух. При застойных явлениях (отеке легких, цианозе) кровопускание (300—400 мл) и другие отвлекающие мероприятия: пиявки, горчичники, банки, вдыхание кислорода. После кровопускания — внутривенное введение глюкозы, лучше со строфантом. Под кожу кофеин, камфора, препараты наперстянки. При коллапсе вводят сначала адреналин, далее — возбуждающие средства (кофеин, камфора, стрихнин, лобелин), а затем кордиамин, дигиталис и его препараты.

Кровопускание нельзя делать при значительном падении кровяного давления (например, при коллапсе). Rp. Sol. Glucosi 40% 30,0 T-gae Strophaulhi gtt. II Striclisetur! MDS. Для внутривенного введения

Rp. Ol. camphorati 20% 2,0 D. t. d. N. 12 in amp. S. По 2 мл под кожу через 2 часа

Rp. Sol. Coffeini natrio-benzoici 20% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 ампуле под кожу 3 раза в день

Rp. Sol. Corazoli 10% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл 1—2 раза в день под кожу

Rp. Cordlamini 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 мл 1—2 раза в день под кожу Rp.

Sol. Strychnini nitric! 0,1% 1,0

D. t. d. N. 4 in amp.

S. По 1 мл под кожу 1—2 раза в день Rp.

Sol. Adrenalin! hydrochlorici 0,1% 1,0

D. t. d. N. 4 in amp.

S. По 1 ампуле 1—2 раза в день под кожу Rp.

Inf. fol. Digitalis ex ^3,6:200,0

DS. По 1 столовой ложке 4 раза в день ' Rp.

Digalen-Nro 1,0

O. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 ампуле 2 раза в день под кожу или внутривенно

Rp. Gitalin: 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 1 ампуле внутривенно или подкожно 2 раза в день Rp.

Sol. Ephedrine hydrochlorici 5% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,5—1,0 под кожу Rp. Sol.

Lobeline hydrochlorici 1% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,5—1,0 под кожу

Очищение кишечника, ограничение питья, частые приемы пищи небольшими порциями, причем она должна быть высококалорийной (питательной), полужидкой или в протертом виде. При похолодании конечностей — грелки, растирания, при значительных потерях крови — переливание крови (осторожно!).

(Помощь при обмороке см. гл. XVI. *Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях*.)

**СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯ.** Хроническая сердечная недостаточность развивается постепенно у лиц с заболеванием сердечной мышцы. При пороках сердца, кардиосклерозе, миокардите, миокардиодистрофии мышечные волокна постепенно перерождаются, атрофируются и заменяются соединительной рубцовой тканью, вследствие чего постепенно осла-



беваст сердечная деятельность и развивается декомпенсация, или недостаточность сердца. Сосудистая недостаточность развивается постепенно, вследствие нарушения сосудистого тонуса и развития склеротических изменений в стенках сосудов, отчего нарушается кровоснабжение различных органов. Часто сердечная недостаточность комбинируется с сосудистой.

**Симптомы и течение.** Основные симптомы сердечной недостаточности: одышка, цианоз и отеки. Сердце увеличено в размерах, тоны сердца приглушенные или глухие, иногда их едва удается прослушать (при пороках сердца выслушиваются сердечные шумы), пульс частый слабого наполнения, неправильный.

Различают три стадии сердечной недостаточности (декомпенсации). В первой стадии больные в покое не ощущают никаких болезненных явлений. При быстром движении, подъемах по лестнице, усиленном физическом труде появляется более или менее значительная одышка и учащение пульса. Больные быстро утомляются, иногда ощущают сердцебиение. Сердце умеренно увеличено, тоны приглушены.

Во второй стадии все эти явления усиливаются: одышка наступает более быстро, пульс учащается, сердце увеличивается в своих размерах, его тоны становятся глуше; появляются подкожные отеки и застойные явления в различных органах. При недостаточности главным образом правого желудочка наблюдается застой в большом кругу кровообращения, отеки на ногах, сначала только к вечеру, а затем постоянные; увеличение печени, застой в почках (немного белка в моче, гиалиновые цилиндры); губы, кончик носа, щеки, пальцы рук и ног несколько цианотичны. При недостаточности левого желудочка — застойные явления главным образом в легких: кашель с мокротой и хрипы в легких (см. *Астма сердечная и Отек легких*). При постельном режиме и соответствующем лечении явления декомпенсации могут совершенно исчезнуть, и больной может вновь стать трудоспособным.

В третьей стадии все указанные явления значительно усиливаются: цианоз усиливается, одышка наблюдается даже в покое, в положении (больные могут спать только в приподнятом или даже сидячем положении); отеки увеличиваются; появляется асцит, иногда гидроторакс и т. д.; в тяжелых случаях — застойные явления в слизистой желудка и кишечника; аппетит понижен, часто тошнота и рвота. Всасывательная функция кишечника понижается, появляются поносы. Застойные явления в почках, почках и легких нарастают. При лопожелудочковой недостаточности, чаще по ночам, возникают приступы сердечной астмы, а затем явления отека легких. Сердце значительно растягивается, пульс становится частым, малым и аритмичным. Если терапевтические мероприятия не улучшают состояния, больные погибают при явлениях нарастающей сердечной недостаточности.

**Лечение.** В первой стадии недостаточности: установление щадящего режима для сердечной мышцы; перемена профессии, если она связана с тяжелым физическим трудом, регулярный отдых; больной должен избегать переутомления, ограничить питание, соблюдать умеренность в еде, наблюдать за регулярным действием кишечника,

пики, не курить и не употреблять спиртных напитков. При первой стадии недостаточности допустим нетяжелый физический труд. Показаны дозированные занятия физкультурой под контролем врача, фельдшера (лечебная физкультура) и лечение на курортах углекислыми и сероводородными ваннами (Кисловодск, Магиста).

Из лекарственных средств дают не сильнодействующие сердечные средства: адонилон, стрихнин с валерианой и ландышевыми каплями. При второй стадии недостаточности больной становится нетрудоспособным. Назначается постельный режим; при застойных явлениях в легких — банки, горчичники; для лучшего отхождения мокроты — отхаркивающие средства (ипекакуана, апоморфин, сенега, термопсис); при сильной одышке — наркотические (кодеин, героин, дионин, морфин); сердечные средства: камфора, кофеин, диуретин, стрихнин, наперстянка, адонилон (по 15 капель 3 раза в день) и строфант (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность острая*).

Rp. Inf. Adonis vernalis 6,0—200,0

DS. Через 3 часа по столовой ложке

Rp. T-rae Strychni 5,0

T-rae Valerianae simplicis

T-rae Convallariae majalis aa 10,0

MDS. По 25 капель 3 раза в день

Rp. Strychnini nitrici 0,06

Massae pilularum q. s. ut f. pil. N. 60 DS. По 1

пилюле 2 раза в день

Rp. T-rae Strophanthi 10,0

DS. По 5 капель 3 раза в день Rp.

Diuretini 0,5

D. t. d. N. 12 in tabul.

S. По 1 таблетке 3' раза в день

После некоторого восстановления компенсации" этим больным показано санаторное лечение (курортное — противопоказано), лечебную физкультуру желательнее начинать еще во время пребывания больных в постели.

Больные в третьей стадии сердечной недостаточности являются полными инвалидами и находятся в постели. Полный покой, приподнятое и удобное положение тела, чистый, свежий воздух, ограждать больного от всевозможных волнений и заботиться о достаточном сне. При бессоннице и нервном возбуждении успокаивающие и снотворные средства (бромиды, валериана, люминал).

Rp. Inf. rad. Valerianae ex 8,0—200,0 - Natrii

bromati 8,0

Codeini phosphorici 0,2

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день Rp

Luminali 0,05

D. t. d. N. 6 in tabul.

S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Во избежание пролежней тщательно следить за кожей, поворачивать больного, подкладывать резиновый круг. Ограничить питье; пища — легкая, малосоленая, без острых и экстрактивных приправ, в протертом и размолотом виде, частая еда небольшими порциями. Следить, чтобы кишечник работал исправно, в случае надобности назначать слабительные (английская соль, ревень) или клизму.

Внимательно следить за суточным диурезом. Особенное внимание уделяют пульсу больного, его дыханию. При сильной одышке, венозном застое, застое в легких — кровопускание (200—400 мл) или пиявки к затылку или копчику (G—8 пиявок).

Наперстянка в больших дозах и ее препараты, инъекции камфоры, коразола, кофеина, стрихнина, адреналина, внутривенные вливания глюкозы в чистом виде или со строфантом (см. *Сердечнососудистая недостаточность острая*).

При сильной одышке — инъекции морфина или омнопона (пантопона), иногда одновременно с камфорой, а также вдыхание кислорода, особенно при наличии цианоза. Кроме диуретика, применяют более мощное мочегонное средство — меркузал.

Вр. Mercusali 2,0

D. t. d. N. 4 in amp.

С. По 1—2 мл внутримышечно или внутривенно 1 раз в 3—5 дней

Меркузал нельзя давать при воспалении почек. При похолодании конечностей — грелки.

**СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ НЕВРОЗЫ** см. *Неврозы сердечно-сосудистые*.

**СЕРДЕЧНЫЙ ПРИПАДОК** см. *Астма сердечная, Инфаркт миокарда, Стенокардия, Неврозы сердечно-сосудистые*,

**СИДЕРОЗ** см. *Пневмококиоз*.

**СИЛИКОЗ** см. *Пневмококиоз*.

**СИФИЛИС АОРТЫ** см. *Аортит*.

**СИФИЛИС ПЕЧЕНИ. ГЕПАТИТ СИФИЛИТИЧЕСКИЙ (SYPHILIS HEPATIS, HEPATITIS LUETICA)**. Сифилитическая инфекция может вызвать острый паренхиматозный гепатит. Чаще он протекает хронически с последующими цирротическими изменениями в печени. Обычно в печени наблюдается гуммозный процесс: гуммы постепенно распадаются, замещаются соединительной тканью, в результате чего образуются рубцы, стягивающие здоровые части печени; печень становится плотной и бугристой, как бы разделенной на отдельные части (Дольчатая печень).

**Симптомы и течение.** Острый паренхиматозный сифилитический гепатит протекает с симптомами обычного гепатита: желтухой, увеличенной и болезненной печенью и повышенной температурой. Характерный признак сифилитического цирроза — плотная, бугристая (дольчатая) печень; селезенка увеличена; впоследствии развивается асцит, желтуха (вследствие сдавления воротной вены и желчных протоков).

**Распознавание.** При наличии острого гепатита нужно дифференцировать с гепатитами другой этиологии; при гуммозном и цирротическом процессе — с другими циррозами и раком печени.

**Лечение.** В основном лечение специфическое: новарсенол, ртуть, биохинол, иод (см. *Аортит*). Нужно быть осторожным с применением новарсенола, особенно при наличии желтухи, так как новарсенол сам по себе может вызвать токсический гепатит (сальварсановая желтуха). Диета, общий режим и неспецифическое лекарственное лечение назначаются те же, что при обычных гепатитах (см.) и циррозах печени (ел.).

**СКОРБУТ** см. *Цынга*.

**СПАЗМ ПИЩЕВОДА** см. *Невроз пищевода*.

**СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА** см. *Пищевода сужение*.

**СТЕНОКАРДИЯ. ГРУДНАЯ ЖАБА (STENOCARDIA, ANGINA PECTORIS)**. Приступы сильных болей в области сердца или за грудиной с отдачей в левое плечо, лопатку, руку, шею и затылок. Эти приступы развиваются вследствие спазма сужения венечных (коронарных) артерий, отчего нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. Различные нервные возбуждения, перенапряжение психики, переутомление высших нервных центров вызывают приступы стенокардии. Стенокардия в большинстве случаев появляется в пожилом возрасте. При стенокардии обычно наблюдается склероз венечных сосудов (коронаросклероз). Склерозированные артерии сильнее реагируют на различные раздражения.

Непосредственные причины приступа: физические напряжения, возбуждение нервной системы, психические травмы, отравление табаком, злоупотребление пищей и спиртными напитками, влияние холода и др.

**Симптомы и течение.** Приступы часто наступают внезапно, во время движения или физического напряжения (могут быть приступы и ночью во время сна). Появляется стеснение в груди и боли жгучего, давящего или режущего характера. Лицо бледнеет, выступает холодный пот, холодеют конечности. Часто появляется сильная одышка (см. *Астма сердечная*), пульс делается слабым и неправильным. Приступы могут продолжаться всего несколько минут, иногда дольше; могут повторяться несколько раз в день или по появляться в течение нескольких лет. Больной может погибнуть во время первого приступа (наступление инфаркта миокарда).

**Распознавание.** Нужно определить, является ли приступ следствием\* сердечного невроза или склероза коронарных сосудов, а затем установить, имеется ли только приступ стенокардии или он осложнен инфарктом миокарда (см.).

**Лечение.** Во время приступа — полный покой, сидячее положение в постели. На сердце — грелку или горчичник, к ногам и рукам — грелки или ручные и ножные горячие ванны; внутрь амилнитрит или нитроглицерин (расширяет венечные артерии), а также атропин (ангиспазматическое средство).

Вр. Amylii nitrosi 5,0

DS. Накапав на ватку 3—5 капель, осторожно вдыхать

Ftp. Sol. Nitroglycerin spiriti. 1% 5,0

US. 1—2 капли на прием при болях в сердце. (Накапать на кусочек сахара. Давать больному сосать, чтобы нитроглицерин всасывался слизистой оболочкой полости рта)

15p. Nitroglycerin! 0,0005 U. U

A. N. 12 in tabul.

S. По 1 таблетке при болях в сердце. Таблетки также нужно держать во рту, лучше под языком, до полного их растворения

Пр. Pol; Atropini sulfurici 0,1% 1,0 D. t. d.

N. 6 in amp. S. Но 1 мл под кожу

Если указанные средства не успокаивают боли, то всегда нужно думать о возможности наличия инфаркта миокарда. Тогда прибегают к инъекциям морфина или опиоидов.

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici! 1% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 0,5—1 мл 1—2 раза в сутки под кожу

Rp. Sol. Omnoponi 2% 1,0 D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 ампуле 1—2 раза в сутки под кожу

После приступа — средства, успокаивающие нервную систему и расширяющие венечные сосуды: бромиды, люминал, диуретин, папаверин, сальсолин, платифиллин (см. *Гипертоническая болезнь*). Для улучшения питания сердечной мышцы — внутривенные вливания глюкозы. Для уменьшения свертываемости крови, чтобы предупредить тромбоз коронарных сосудов (инфаркт миокарда), применяют новый препарат — дикумарин по 0,05—0,1 два-три раза в день (дикумарин можно принимать только под наблюдением врача). При ослаблении сердечной деятельности — сердечные средства (см. *Астма сердечная*); при коронаросклерозе — йодистые препараты, гиперсол (см. *Артериосклероз*). Если в анамнезе имеется сифилис — противосифилитическое лечение (см. *Аортит*).

<

СУЛЕМОВАЯ ПОЧКА см. *Некронефроз*.

ТРАХЕИТ (TRACHEITIS) — воспаление дыхательного горла. Обычно наблюдается одновременно с поражением верхних дыхательных путей — ринитом (насморк), фарингитом (воспаление зева) и ларингитом (воспаление гортани) или еще чаще с бронхитом; причины трахеита одинаковы с этими болезнями (см. *Болезни уха, горла и носа*) и бронхитом. Трахеит может быть острым и хроническим.

Симптомы и течение. При изолированном трахеите наблюдается кашель, иногда очень мучительный, приступообразный, сначала сухой, а затем с небольшим количеством вязкой, слизистой, трудно отделяемой мокроты. Часто ощущаются боли, чувство царапания за грудиной. От сильного кашля появляются боли в грудной клетке (вследствие перенапряжения дыхательных мышц).

При перкуссии и аускультации никаких изменений в легких не обнаруживается. Острый трахеит, вызванный инфекцией, сопровождается повышенной температурой.

Распознавание. Изолированный трахеит нужно отличать от ларингита и бронхита.

Лечение. При значительной лихорадке (температура 38° и выше) постельный режим. При сильном кашле и болях наркотические средства (героин, кодеин); при трудно отделяемой мокроте отхаркивающие (сеиега, термолис) (см. *Бронхит*). Можно комбинировать наркотические с отхаркивающими.

На грудь горчичники, пить горячее молоко с содой ( $\frac{1}{2}$  чайная ложка на стакан) или со щелочными минеральными водами (полстакана молока и полстакана боржоми). Ингаляции с содовой водой (2%), скипидаром (1 чайная ложка на стакан воды), ментолом.

Пр. Mentholi 1,0

Spiritus Vini rectificati 95° 20,0

MDS. Прибавляют 25^30 капель к кипящей воде для ингаляции

ТРОМБОПЕНИЯ (TROMBOPENIA), ВЕРЛЬГОФА БОЛЕЗНЬ (MORBUS WERLHOFF). Причина неизвестна. Считают, что болезнь возникает вследствие уменьшения образования тромбоцитов в костном мозгу при нарушении функции селезенки, приводящем к угнетению функции образования тромбоцитов. От этого, вероятно, происходят изменения в стенках капилляров (повышение их проницаемости).

Различные инфекции и интоксикации могут способствовать возникновению болезни. Усиление кровоточивости в связи с нервными возбуждениями и психическими потрясениями говорит о влиянии нарушений нервной регуляции в развитии болезни.

Симптомы и течение. Основной симптом — кровоточивость слизистых оболочек десен, полости рта, носа и т. д. У женщин — обильные, продолжительные менструации, иногда переходящие в маточные кровотечения. Характерны точечные кожные кровоизлияния (петехии). Даже от легких ударов по телу образуются внутрикожные кровоизлияния (синяки); от частых и продолжительных кровопотерь развивается малокровие. Селезенка увеличена.

Вследствие частых и продолжительных кровопотерь у больных развивается малокровие с уменьшением количества гемоглобина и красных кровяных телец. Больные становятся нетрудоспособными, у них появляется общая слабость, головокружение, ослабление деятельности сердца, вплоть до коллапса.

Болезнь протекает хронически, с временными улучшениями и последующими рецидивами. Уменьшение в крови тромбоцитов (красных пластинок) до 35 000—30 000 в 1 мм<sup>3</sup> и меньше (при норме 250 000—350 000).

Лечение. Во время и после кровотечения постельный режим. Вливание под кожу нормальной лошадиной сыворотки (до 100 мл) и хлористого кальция внутривенно по 10 мл; в тяжелых

случаях переливание крови. Витамины: С (аскорбиновая кислота) и К (викасол).

Rp. Sol.- ac. ascorbinici 5% 1,0 D. t. d. N. 10  
m amp. S. По 1 ампуле 1—2 раза в день

Rp. Vicasoli 0,015  
D. t. d. N. 12 in tabul.  
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Если болезнь прогрессирует, удаляют селезенку (спленэктомия), после чего часто наступает значительное улучшение. (Лечение малокровия см. *Анемия, лечение.*)

### ТУБЕРКУЛЕЗ КИШОК (TUBERCULOSIS INTESTINI).

Большей частью является осложнением туберкулеза легких: туберкулезные палочки попадают в кишечник с проглоченной мокротой или гематогенным путем, вызывая воспаление слизистой, обычно с образованием язв (язвенный энтерит или энтероколит).

**Симптомы и течение.** Упорные поносы, часто не поддающиеся лечению, иногда чередующиеся с запорами. Боли в животе, урчание, метеоризм (вздутие живота). Испражнения с примесью скрытой крови и гноя с резким тухлым запахом. Палочки Коха в испражнениях обычно не удается обнаружить. Состояние больного, вследствие общей интоксикации, а также пониженного питания, значительно ухудшается. Плохой аппетит, повышенная температура, нарастающая слабость и анемия. Общее ослабление организма может повести в свою очередь к ухудшению легочного процесса, поэтому туберкулез кишок часто является конечной стадией туберкулеза легких.

**Распознавание.** Дифференцировать с неспецифическими острыми и хроническими кишечными катаррами и кишечными инфекциями (хроническая дизентерия и др.).

**Лечение.** Общеукрепляющее, ПАСК, стрептомицин (см. *Туберкулез легких*). Разнообразная и высококалорийная\*; но в то же время щадящая противоположная пища (см. *Энтерит острый и хронический и гастроэнтероколит. острый*). В остальном — симптоматическое лечение. Режим постельный.

### ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ (TUBERCULOSIS PULMONUM).

Возбудитель — туберкулезная палочка (палочка Коха). Туберкулезная палочка проникает в организм главным образом через дыхательные пути и реже через кишечник. Источником заражения является в основном мокрота, выделяемая больными туберкулезом. Заражение происходит капельным путем через частицы мокроты и слюны, выделяемые больным при кашле, разговоре, чихании. Инфекция передается и копт а к т н ы м путем от соприкосновения с больным и через предметы, окружающие больного, на которые попадают незаметные частицы мокроты (при пользовании больным общей посудой, полотенцем, носовыми платками и пр.). Высохшая мокрота, превращаясь в пы л ь, также может вызвать заражение. Причины, ослабляющие организм, уменьшающие его сопротивляемость, способствуют развитию туберкулеза.

Сюда в первую очередь относятся с о ц и а л ь н ы е причины: плохое и недостаточное питание; сырое, темное и скученное жилище; низко оплачиваемый труд, тяжелые, вредные и антисанитарные условия труда, безработица. Поэтому в капиталистических странах, и еще больше в колониальных, туберкулез легких чрезвычайно распространен.

**Формы классификация туберкулеза.** Основными патологическими процессами является и р о д у к т и в н о е (образование туберкулезной грануломы или бугорка) и э к с с у д а т и в н о е воспаление.

На месте проникновения туберкулезных палочек образуется один или несколько очагов ( п е р в и ч н ы й а ф ф е к т ). Вокруг очага развивается экссудативно-воспалительный процесс, который обычно распространяется на ближайшие лимфатические узлы. Первичный очаг вместе с пораженными лимфатическими узлами носит название п е р в и ч н о г о к о м п л е к с а .

Первичные очаги обычно заживают, рубцуются.

Повторное заражение происходит путем вторичного попадания туберкулезных палочек или путем их поступления из старого очага. При этом обычно развивается воспалительный туберкулезный процесс — легочный инфильтрат, который может подвергнуться обратному развитию, рассасыванию с последующим рубцеванием или же- распаду.

Очаговое продуктивное воспаление сопровождается значительным разрастанием соединительной (фиброзной) ткани — и р о д у к т и в н о - ф и б р о з н ы й т у б е р к у л е з . Туберкулезный очаг может подвергнуться творожистому или казеозному распаду, вследствие чего образуются каверны (полости) — ф и б р о з н о - к а в е р н о з н ы й т у б е р к у л е з л е г к и х ( л е г о ч и а я ч а х о т к а ). При экссудативном воспалении (инфильтративная форма) в легочную ткань и альвеолы выделяется серозный экссудат. Такие пневмонии образуются вокруг туберкулезных очагов и протекают как очаговые пневмонии, которые могут закончиться заживлением (рубцеванием) или распадом с образованием каверны. Иногда туберкулезная пневмония развивается остро с последующим творожистым распадом — к а з е о з н а я п н е в м о н и я ( с к о р о т е ч н а я ч а х о т к а ). Если в ток крови попадает большое количество палочек, то происходит обсеменение многочисленными бугорками (мелкими очагами) не только легких, но п. других органов (плевры, брюшины, кишечника, почек, мозговых оболочек п пр.) — м и л и а р н ы й т у б е р к у л е з .

Помимо формы туберкулеза, важно знать распространение процесса. Для этого каждое легкое условно делят на три части, на три поля — верхнее, среднее и нижнее, которые соответственно обозначают 1, 2, 3. В числителе отмечают распространение процесса в правом

14-2 легком, в

знаменателе — в левом. Например, —±— будет обозначать, что туберкулезный процесс наблюдается в верхнем и среднем поле правого легкого и в нижнем поле левого легкого.

Независимо от степени распространенности процесса последний может протекать медленно, без распада легочной ткани, пли, наоборот, очень бурно, с быстрым распадом легочной ткани.

Если процесс выражается только в разрастании соединительной ткани, клинически болезнь мало проявляется и больной трудоспособен, то такой процесс обозначают буквой А (компенсированный туберкулез легких). Если имеется воспалительный легочный процесс с выделением мокроты, часто содержащей туберкулезные палочки, то его обозначают латинской буквой В (субкомпенсированный туберкулез легких). Бурно протекающий туберкулез с быстрым распадом легочной ткани обозначается латинской буквой С (декомпенсированный туберкулез легких).

При открытых формах туберкулеза в мокроте больных обнаруживаются туберкулезные палочки, обозначаемые БК (-, при их отсутствии БК —. Наличие каверны условно обозначается буквами КВ.

Чтобы иметь ясное представление не только о диагнозе туберкулезного процесса, но и о его распространенности, о выделениях туберкулезных палочек, о степени компенсации, к диагнозу присоединяют соответствующие обозначения. Например, пишут так:

«фиброзно-кавернозный туберкулез В —т<sup>1+2</sup>—БК+».

О п м и т о м ы. Для туберкулеза характерна ремиттирующая (послабляющая) температура; в легких и хронических случаях — небольшие повышения температуры по вечерам (37,2—37,5°); в тяжелых (скоротечная чахотка, милиарный туберкулез) — температура по вечерам может доходить до 39—40° и носить характер гек-тической (изнуряющей) лихорадки. При нормальной или суб-фебрильной температуре — ночные поты, иногда холодные. При высокой температуре, гектической лихорадке бывают профузные (обильные) поты. Кашель может быть сухой или с выделением мокроты. Иногда частый и мучительный кашель сильно беспокоит больного, не дает ему спать, вызывает боли в грудной клетке. Мокрота слизистая, слизисто-гнойная и гнойная; при открытых формах в мокроте находятся туберкулезные палочки в тяжелых случаях — при быстром распаде легочной ткани и наличии каверн — выделяется много гнойной мокроты с большим количеством палочек. Кровахаркание — результат разрушения стенок капилляров и мелких кровеносных сосудов, а легочное кровотечение — крупного сосуда. При вдохе кровь может попасть в здоровые части легких и вызвать аспирационную пневмонию с возникновением новых туберкулезных очагов. При поражении обоих легких наблюдается одышка (вследствие уменьшения дыхательной поверхности легких); одышка усиливается от присоединившейся слабости сердца. Боль при дыхании и кашле указывает на вовлечение в процесс плевры. Иногда боль бывает при сильном кашле вследствие напряжения мышц грудной клетки.

Наблюдается ослабление деятельности сердца: одышка усиливается, пульс становится частым, слабого наполнения.

Развивается малокровие (вторичная токсическая анемия); понижение аппетита, похудание и общее истощение организма.

Перкуссия и аускультация. Притупление легочного звука наблюдается при воспалительных очагах, при разраста-

нии фиброзной ткани, сморщивании легких вследствие рубцевания. Каверны значительной величины дают тимпанический звук. Жесткое или бронхиальное дыхание выслушивается при уплотнении легочной ткани вследствие воспалительного или фиброзного процесса. При аускультации каверны выслушивается бронхиальное или амфорическое дыхание. В случае воспалительного процесса, особенно при экссудативных формах, выслушиваются различные сухие, влажные и крепитирующие хрипы.

Течение. Туберкулез может протекать самым различным образом: от легких форм, когда больной является практически здоровым и даже сам не подозревает о наличии болезни, до тяжелых (скоротечная чахотка, милиарный туберкулез), когда больной погибает в течение нескольких месяцев.

Наблюдаются случаи полного излечения туберкулеза легких. В большинстве случаев туберкулез протекает годами, медленно, хронически. Течение болезни зависит от бытовых условий (питание, жилище), соблюдения режима и отдыха, условий труда. Обычно периоды ухудшения сменяются периодами улучшения и даже видимого выздоровления. Обострения процесса наблюдаются чаще весной и осенью с последующим улучшением зимой и летом. Течение болезни резко ухудшается, если присоединяются различные осложнения: переход туберкулезного процесса с легкого на другие органы (кишечник, почки, брюшину и т. д.). Наиболее тяжелые осложнения — туберкулезный менингит и милиарный туберкулез.

Распознавание. Туберкулез легких нужно отличать от других легочных заболеваний: бронхитов, пневмоний, абсцесса легкого, бронхоэктазов, пневмокониозов и пневмосклерозов. Точный диагноз иногда удается поставить только после нахождения в мокроте туберкулезных палочек или при рентгенологическом исследовании.

Милиарный туберкулез, который иногда протекает без кашля и других легочных симптомов, можно смешать с брюшным тифом, сепсисом, эндокардитом.

Профилактика. Основная задача — оградить здоровых от проникновения инфекции. Мокроту больных нужно аккуратно собирать в специальные плевательницы и дезинфицировать лизолом (5% раствор), хлорамином (3% раствор).

Rp. Lysoli 5% 500,0

DS. Для дезинфекции мокроты

Rp. Sol. Chlorammi 3% 500,0

DS. Для дезинфекции мокроты

Этими растворами также замачивают белье, которым пользовался больной. Плевательницы можно кипятить вместе с мокротой. Больного, выделяющего палочки, необходимо отделить от здоровых (отдельная комната, отдельная кровать, отгороженная ширмой; отдельная пелена, полотенце, носовые платки и пр.).

Больной, в особенности с открытой формой туберкулеза легких, долями полоскать рот, часто мыть руки, иметь при себе карманную плевательницу для мокроты и пр. Солнечный свет, свежий воздух

и чистота являются основными профилактическими мероприятиями против туберкулезной инфекции.

Накаливание тела, занятия физкультурой, холодные обтирания, здоровый образ жизни предохраняют от заболевания туберкулезом.

Среди новорожденных проводят вакцинацию против туберкулеза.

Большую профилактическую и лечебную работу ведут туберкулезные диспансеры.

Туберкулезные диспансеры, а на селе врачебные и фельдшерские пункты берут на учет в своем районе не только явно больных туберкулезом, но и всех подозрительных больных, а также живущих совместно с бацилловыделителями и проводят необходимые лечебные и профилактические мероприятия.

Помимо лечебной работы, диспансеры ведут огромную санитарно-просветительную, профилактическую работу по оздоровлению труда и быта широких масс населения.

Лечение. Регулирование трудового режима; освобождение от работы на вредных производствах. Необходим достаточный отдых, здоровые жилищные условия, занятия легким спортом, закаливание организма. Пища должна быть разнообразной, богатой витаминами, содержать достаточное количество питательных веществ.

Самым лучшим лечением начальных и средних форм туберкулеза (компенсированных и субкомпенсированных) является санаторное и курортное лечение. Санаторное лечение имеет то преимущество, что больной временно освобождается от своих обычных занятий и проводит лечение под наблюдением врачей в санатории, расположенном за городом.

Кроме того, санаторное лечение имеет громадное воспитательно-просветительное значение: больной приучается соблюдать чистоту, собирать и дезинфицировать мокроту, во время питания, вести регулярный образ жизни, измерять температуру и вообще более бережно относиться к своему здоровью.

Лечение больных туберкулезом на курорте — это то же санаторное лечение, но только в более благоприятном для климата. Курорты устраиваются на юге, на берегу моря, в горах, в сосновых лесах или в степях, где больше света и чище воздух.

В степных курортах Башкирской АССР, Чкаловской области, Казахской АССР климатическое лечение сочетается с кумысолечением.

Кумыс — кобылье сброженное кислое молоко, содержащее от 1 до 3% алкоголя. Это вкусный, питательный, легко усваиваемый напиток; больные охотно его пьют. На кумыс рекомендуется направлять истощенных, ослабленных больных с плохим аппетитом.

На курорты направляют только больных, находящихся в состоянии компенсации и субкомпенсации. Нельзя посылать на курорты больных с температурой выше 38°, с кровохарканием, резкой одышкой и явлениями резко выраженной сердечной недостаточности. В санаториях, как и на курортах, больные часто выздоравливают.

В некоторых случаях наблюдается даже преимущество местного санаторного лечения, так как больные иногда быстрее выздоравливают в том климате, в котором они постоянно живут. Если при-

чиной заболевания явились отрицательные условия труда больного, ему надо переменить свою профессию или место работы.

В тяжелых случаях туберкулеза, в стадии декомпенсации, больных направляют в туберкулезные больницы.

В последние годы открыто новое специфическое средство против туберкулезной палочки — стрептомицин, который при некоторых формах легочного туберкулеза дает прекрасный лечебный эффект.

Кроме того, стрептомицин излечивает иногда туберкулезный менингит и острый милиарный туберкулез, которые раньше не поддавались никакому лечению.

Стрептомицин оказывает хорошее действие при тяжелых формах туберкулеза гортани и кишечника. Препарат вводят внутримышечно. Техника разведения и впрыскивания та же, что при пенициллине (см. *Абсцесс легкого*).

Обычная суточная доза стрептомицина — 1 000 000 единиц; это количество содержится в 1 г сухого стрептомицина. Инъекции производят 3 или 2 раза в сутки, т. е. всю суточную дозу делят на 2 или 3 инъекции. В настоящее время стали применять новый препарат — парааминосалициловую кислоту (ПАСК). Этот порошок применяют внутрь от 7 до 15 г в суткп. Суточную дозу делят на 5—7 равных частей, которые дают в течение всего дня. Курс лечения составляет 2—4 месяца. У больных с тяжелой формой туберкулеза легких, гортани и кишечника лечение этим препаратом дает значительное улучшение.

При сильном кашле дают наркотические средства (кодеин, дионин, героин и иногда морфин). Для лучшего отхождения мокроты — отхаркивающие (апоморфин, ипекакуана, сенег, термопсис) (см. *Абсцесс легкого*, *Бронхит острый*). При туберкулезе широко применяют отхаркивающие дезинфицирующие средства: терпингидрат, тиокол, гваякол, иногда в комбинации с наркотическими.

Rp. Dionini 0,015  
Thlocoli 0,5  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1  
порошку 3 раза в день

Rp. Guajacoli carbonici 1,0 D. t. d. N. 10  
S. \*По 1 порошку 3 раза в день

Лечение кровохаркания и легочного кровотечения см. *Кровотечение легочное*. При значительном потении — атропш.

Rp. Atropini sulfurici 0,02  
Extr. ct pulv. Liquiritiae q. s. M. ut f. pil. N. 40 DS. 1  
пилюлю вечером

При ослаблении сердечной деятельности — сердечные средства (кофеин, камфора, стрихнин, наперстянка). При начальном остром туберкулезе (кавернах, инфильтратах), особенно одностороннем, с успехом проводят лечение путем искусственного пнев-

мол. о. ра к са (введение в полость плевры воздуха или азота). Благодаря широкому лечебно-профилактическому мероприятиям и в особенности общему улучшению жизни в Советском Союзе, заболевание туберкулезом у нас неуклонно из года в год снижается.

ТУБЕРКУЛЕЗ МИЛИАРНЫЙ см. *Туберкулез легких.*

ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЧЕК см. гл. VI. *Хирургические болезни.*

УРЕМИЯ см. *Нефрит острый. Нефрит хронический.*

ХЛОРОЗ. БЛЕДНАЯ НЕМОЧЬ (CHLOROSIS). Особый вид малокровия, наблюдающийся иногда у девушек в период наступления половой зрелости. Как видно, в развитии болезни играют роль нарушения функции эндокринных желез (яичники и др.). Хлороз наблюдается при недостаточном поступлении с пищей железа или при плохом усвоении его организмом.

Симптомы и течение. Резкое уменьшение гемоглобина при незначительном уменьшении числа эритроцитов. При дефиците хлорозе — явления общего невроза: сердцебиение, повышенная возбудимость, истерические реакции. С наступлением половой зрелости явления хлороза обычно проходят.

Лечение то же, что и при анемии. Хорошее действие оказывают на нервную систему: санаторный режим, теплые ванны, купанье, занятия спортом и пр. Из лекарств на первом месте (ТОНТ железо) см. *Анемия*.

ХОЛАНГИТ см. *Холецистит.*

ХОЛЕЦИСТИТ. ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (CHOLECYSTITIS). ХОЛАНГИТ (CHOLANGITIS) или АНГИОХОЛИТ (ANGIOCHOLITIS). ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ. Причины: инфекция, которая может проникнуть в пузырь восходящим (кишечная инфекция) и гематогенным (гноеродные бактерии, гриппозная инфекция) путем; желчные камни; иногда паразиты (печеночная двуустка), а также лямблии. Застой желчи в желчных протоках и пузыре способствует проникновению кишечной инфекции.

Симптомы и течение. Боли в области правого подреберья, редко приступами и не такими интенсивными, как при желчнокаменной болезни. Прощупывается набухшая, болезненная печень, иногда увеличенный и болезненный желчный пузырь. Диспептические явления: тяжесть подложечкой, вздутие живота, отрыжка, тошнота, иногда рвота. Запоры или поносы. Холециститы, не вызванные камнями, протекают без желтухи. Желтуха, обычно не интенсивная, наблюдается при холангитах, когда значительное количество набухших желчных протоков бывает закупорено воспалительным секретом (слизью). Температура, особенно в остром периоде, всегда повышена. При гнойном воспалении болезнь принимает тяжелую форму с высокой ремиттирующей лихорадкой. Часто острый холецистит переходит в хроническую форму: температура нормальна, небольшая боль в области печени, нерезко выраженные диспептические явления. Хронический холецистит, главным образом при нарушениях диетического режима, часто дает обострения.

Распознавание. Надо отличать от острых гепатитов различного происхождения, от язвенной болезни, гастрита, аппен-

дицита. Часто трудно установить, имеется ли одновременно и желчнокаменная болезнь.

Лечение. Покой, грелки, согревающие компрессы, теплые или горячие ванны. Пищевой режим и лекарственная терапия (см. *Желчнокаменная болезнь и Гепатиты острые*). Если холецистит вызван гноеродными бактериями, назначают курс лечения пенициллином (см. *Абсцесс легких*). В хронических и подострых случаях — повторное дуоденальное зондирование: после получения желчи через зонд (порция А) вводят в двенадцатиперстную кишку 50 мл 30% раствора сернокислой магнезии для получения изузырного рефлекса; в течение 1—2 часов откачивают желчь; под конец зондирования хорошо ввести дополнительно 200 мл 5% раствора сернокислой магнезии. Кроме того, назначают дезинфицирующие средства: салол, уротропин, иногда с белладонной. При наличии лямблий в желчном пузыре и желчных путях — акрихин (по 0,1 три раза в день в течение 5 дней). Лучше акрихин вводить непосредственно в двенадцатиперстную кишку через дуоденальный зонд: 0,3 акрихина на 10,0—20,0 воды, через час — внутрь 30,0 слабительной соли.

Через 7—10 дней курс лечения акрихином можно повторить. При гнойном холецистите — оперативное удаление желчного пузыря. ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ, ГЕПАТИТЫ ХРОНИЧЕСКИЕ. ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ (CHRONIC HEPATITIS, HEPATITIS CHRONICA). Острые гепатиты и в первую очередь болезнь Боткина часто переходят в хроническую форму (хронический гепатит). Другие инфекции (малярия, туберкулез, сифилис, бруцеллез) тоже могут вызвать хронический гепатит. Вследствие длительного раздражения печени инфекционными токсинами происходит воспаление печеночной паренхимы, сопровождающееся атрофией печеночных клеток с последующим разрастанием соединительной ткани, которая, уплотняясь, сморщивается, образуя рубцы. Этот патологический процесс называется циррозом. Различные химические яды, в том числе и алкоголь, вызывают дистрофические изменения в печеночной паренхиме с последующей атрофией печеночных клеток, что тоже приводит к циррозу.

В некоторых случаях, вследствие значительного разрастания соединительной ткани в печени, она значительно увеличена, в других, когда печеночная ткань атрофируется и заменяется соединительной тканью, она уменьшена вследствие ее сморщивания (рубцевания). Отсюда различают гипертрофический и атрофический цирроз печени. Известен также сифилитический цирроз печени (см. *Сифилис печени*). При недостаточности сердца печень набухает, увеличивается, образуется так называемая застойная печень. При продолжительном застое в печени развиваются цирротические изменения — так называемый сердечный цирроз печени, наблюдающийся при пороках сердца, как следствие продолжительной хронической недостаточности сердца (правого желудочка).

Симптомы и течение. Цирроз печени — медленно развивающаяся хроническая болезнь. При гипертрофическом цир-

розе — большая плотная печень, желтуха; при атрофическом печень увеличена в начале болезни, а затем становится меньше вследствие «давления воротной вены развивается асцит. При эти циррозах всегда увеличена селезенка. Под кожей живота видны расширенные вены («голова медузы»), компенсирующие до некоторой степени недостаточное воротное кровообращение. Больные жалуются на слабость, худеют, теряют аппетит, у них развивается малокровие; впоследствии присоединяется одышка и ослабление сердечной деятельности. При сердечном циррозе наблюдаются признаки сердечной недостаточности, плотная, гладкая печень, постепенно развивающийся асцит; селезенка обычно не увеличена.

**Лечение.** Запретить алкоголь. При наличии сифилиса, туберкулеза, малярии энергично лечить эти заболевания. Пища преимущественно молочно-растительная, легкая, питательная, не раздражающая. При асците — постельное содержание, мочегонные (в том числе и меркузал) и сердечные средства. При большой водянке живота, стесняющей дыхание и сердечную деятельность, выпускают жидкость путем прокола живота.

**ЦЫНГА (SCORBUTUS).** Развивается при отсутствии или недостатке в организме витамина С (аскорбиновая кислота) (см. *Авитаминозы, гиповитаминозы*). Как чистое заболевание встречается редко. В практике чаще приходится сталкиваться с гиповитаминозом С у больных инфекционными и другими болезнями (в особенности желудочно-кишечными), у беременных женщин.

**Симптомы и течение.** Характерно поражение десен: краснота, припухание, разрыхление, кровоточивость и болезненность. Зубы расшатываются, иногда выпадают. Из рта — дурной, гнистый запах. В коже, мышцах, суставах — кровоизлияния.

Болезнь развивается постепенно: появляется общая слабость, боли в ногах и спине, исчезает аппетит. В легких случаях болезнь может закончиться в течение 1—2 недель, в тяжелых — больные погибают от значительных кровотечений и общего истощения.

**Лечение.** Противоцпгготная, содержащая витамин С пища, в состав которой входят свежие овощи, фрукты и ягоды: капуста, шпинат, помидоры, морковь, лимоны, апельсины, черная смородина, шиповник, салат, картофель, лук, чеснок, хрен, редька, а также пивные дрожжи.

Вследствие болезненности десен и слабости зубов пища должна быть жидкой или во всяком случае мягкой: витаминные соки, приготовленные из указанных овощей, фруктов и ягод.

Аскорбиновую кислоту назначают и в чистом виде.

Rp. Ac. ascorbinici 0,1 Sacchari albi 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 10 S. По 1  
порошку 3 раза в день

Rp. Sol. ac. ascorbinici 5% 10,0  
Steriliscitur!

DS. По 2—3 мл (внутримышечно или внутривенно) 1—2  
раза в день

При воспалении десен см. *Заболевания зубов и полости рта, лечение*. При воспалении суставов — согревающие компрессы.  
**ЧАХОТКА ЛЕГОЧНАЯ** см. *Туберкулез легких*. **ШОК** см. *Сердечно-сосудистая недостаточность острая* и гл. VI. *Хирургические болезни*.

**ЭКСТРАСИСТОЛИЯ** см. *Аритмии*.

**ЭМПИЕМА** см. *Плеврит гнойный*.

**ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ (EMPHYSEMA PULMONUM).** Расширение легких, вызванное растяжением легочных альвеол воздухом. Различают острую и хроническую эмфизему. Острая эмфизема (острое расширение легких) наблюдается во время приступа бронхиальной астмы. К острой эмфиземе относится компенсаторная эмфизема, которая появляется в здоровом легком, когда другое легкое, вследствие воспаления или сжатия, не принимает участия в дыхании. Собственно эмфизема легких — хроническая эмфизема, при которой легочная ткань от постоянного растяжения теряет свою эластичность и не в состоянии при выдохе спадаться до нормы. Эмфизема появляется как следствие хронического бронхита, часто повторяющихся приступов бронхиальной астмы, туберкулеза легких, порока сердца. Развитию эмфиземы способствуют врожденное недостаточное развитие эластической ткани в легких, а также ослабление эластичности легких в старческом возрасте.

**Симптомы и течение.** Грудная клетка расширена и приподнята, имеет бочкообразный вид. Первый признак эмфиземы — одышка, которая вначале появляется при усиленной работе, быстрой ходьбе, а затем все более и более усиливается. Эмфизема почти всегда, особенно в далеко зашедших случаях, сопровождается бронхитом (кашель, выделение мокроты). При перкуссии — коробочный звук, нижние границы легких опущены вследствие опущения диафрагмы. При аускультации — ослабленное дыхание, сухие и влажные хрипы. Вследствие изменения в легких затрудняется легочное кровообращение, отчего увеличивается сердечная нагрузка, развивается недостаточность сердца со всеми ее симптомами — легочное сердце (см.). Одышка усиливается, появляется цианоз, отеки сначала на ногах, а затем и в полости живота (асцит).

**Распознавание** на основании анамнеза и приведенных симптомов. Необходимо дифференцировать от хронических сердечных заболеваний (кардиосклероз, миокардиодистрофия).

**Лечение.** Устранение по возможности причин, вызвавших эмфизему. Освободить больного от тяжелой работы, влияния пыли, едких газов и пр. Запретить курение и употребление спиртных напитков.

Лечение бронхита: банки, средства, успокаивающие кашель, отхаркивающие. При осложнении сердечной недостаточностью укрепление сердечной мышцы. При резкой одышке, цианозе и отеках — постельное содержание, приподнятое положение, чистый, свежий воздух; на грудную клетку банки, горчичники; внутрь — наперстянка (Digitalis), диуретин, горицвет (Adonis), под кожу — камфора, кофеин, стрихнин (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность хроническая*).



При пиапозе — пиявки за уши или к копчику (6—8 пиявок) или кровопускание (100—300 мл) с последующим вливанием в вену глюкозы или глюкозы со строфантом; дышать кислородом.

**ЭНДОКАРДИТ (ENDOCARDITIS).** Различают две основные формы эндокардита: ревматический и септический. Ревматический эндокардит, как и ревматическое поражение суставов, большей частью является следствием бывшей ангины, особенно стрептококковой. Септический эндокардит вызывается стрептококком и реже другими гноеродными возбудителями (стафилококками, пневмококками, гонококками). В свою очередь септические эндокардиты подразделяются на острые и затяжные (endocarditis lenta).

**Симптомы и течение.** Клинические эндокардиты делят на доброкачественные (ревматические) и злокачественные (септические). При ревматическом эндокардите поражается чаще митральный клапан, а при септическом — аортальные. Ревматический эндокардит протекает иногда сравнительно легко, с небольшими повышениями температуры ремитирующего характера. При остром септическом эндокардите температура может принимать гектический характер, повышаясь по вечерам до 39—40°. При затяжном эндокардите температура может быть и субфебрильная. Часто при эндокардите наблюдается сердцебиение, боли в области сердца, учащенный, легко, возбудимый, неустойчивый пульс. Большей частью происходит одновременное поражение миокарда (острый миокардит). Тогда появляются признаки сердечной недостаточности. В тяжелых случаях появляются отеки и цианоз. При развитии порока сердца выслушиваются сердечные шумы.

Высокая температура и общая интоксикация вызывают головные боли, головокружение, общую слабость, потерю аппетита, малокровие, похудание. При септическом эндокардите наблюдается увеличение селезенки и значительный лейкоцитоз. При затяжном септическом эндокардите, наоборот, лейкопения. Септический эндокардит часто осложняется нефритом. Тяжелым осложнением является эмболия — закупорка мелких артерий тромбом, оторвавшимся от стенки эндокарда и занесенным током крови в различные органы. При закупорке венечных и крупных мозговых сосудов может наступить моментальная смерть, а при закупорке концевых артерий сердца, почек, селезенки в них образуются инфаркты. Эмболии обычно бывают при септических эндокардитах.

Ревматический эндокардит обычно заканчивается выздоровлением, но часто сопровождается различными осложнениями. В большинстве случаев после эндокардита остается порок сердца. Присоединившийся острый миокардит значительно ухудшает течение болезни. Кроме того, ревматический эндокардит часто дает рецидивы — возвратный эндокардит (endocarditis recurrens). Острый септический эндокардит протекает с резко выраженными тяжелыми явлениями. Больные обычно погибают от общей слабости, нарастающего малокровия и сердечной недостаточности или от различных осложнений (острый нефрит, эмболия и пр.). Затяжной септический эндокардит (endocarditis lenta) протекает нерезко выраженными, но постоянно прогрессирующими симптомами; больные погибают от общей слабости, недостаточности сердца или

присоединившихся осложнений. При лечении пенициллином наблюдаются случаи выздоровления от септического затяжного эндокардита.

**Лечение.** При ревматическом эндокардите — салициловые препараты, пирамидой (см. *Полиартрит ревматический острый*). При септическом эндокардите — сульфаниламидные препараты (см. *Пневмония крупозная*), пенициллин (см. *Лечение пенициллином абсцесса легкого*), дающий даже в безнадежных случаях положительный эффект. В остальном лечение такое же, как и при остром миокардите (см.). Лечение сердечной недостаточности см. *Сердечнососудистая недостаточность*.

**ЭНТЕРИТ ОСТРЫЙ, ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКИХ КИШОК (ENTERITIS ACUTA).** Энтерит обычно бывает одновременно с гастритом или колитом (гастроэнтерит или энтероколит) или с тем и другим (гастроэнтероколит). Причины острого энтерита могут быть те же, что и острого гастрита (см. *Гастрит острый*, *Гастроэнтероколит острый*) или острого колита (см. *Колит острый*). Нужно помнить, что острый энтерит наблюдается и при острых кишечных инфекционных заболеваниях: брюшном тифе и паратифах, холере, туберкулезе кишечника.

**Симптомы и течение.** Основным признаком — понос. Испражнения жидкие или кашицеобразные, большей частью обильные, не очень частые, смешанные со слизью. Энтериты нередко сопровождаются диспепсией бродильной (пенистые испражнения без особого запаха, отхождение большого количества газов) и реже — гнилостной (гнилостные, вонючие испражнения и газы). При энтеритах часто нарушается пищеварение в тонком кишечнике: в испражнениях много непереваренных мышечных волокон, капелек жира, крахмальных зерен; живот вздут, при пальпации небольшая разлитая болезненность.

При инфекционных энтеритах, как и при колитах, наблюдается повышенная температура, достигающая до 39—40°, и явления общей интоксикации: потеря аппетита, головная боль, общая слабость, обложенный язык, помраченное сознание, судороги (при значительном обезвоживании организма). Острый энтерит при правильном лечении и уходе прекращается большей частью в течение нескольких дней; иногда он переходит в хронический. Острые энтериты, наблюдающиеся при брюшном тифе, паратифах, туберкулезе кишечника, имеют своеобразные симптомы и течение.

**Распознавание.** Изолированный острый энтерит нужно дифференцировать с острым гастритом и колитом, а также хроническим энтеритом и инфекционными энтеритами (брюшнотифозным, паратифозным, туберкулезным).

**Лечение.** При нарушении пищеварения — соляная кислота с пепсином и панкреатин (по 0,5 три раза в день после еды).

Rp. Ac. hydrochlorici diluti Pepsini aa 4,0 Aq. destill. 200,0 MDS.

По 1 столовой ложке перед или во время еды

См. *Колит острый, лечение*, *Гастроэнтероколит, лечение*.

**ЭНТЕРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ. ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ТОНКИХ КИШОК (ENTERITIS CHRONICA).** Часто протекает одновременно с колитом (энтероколит), а потому и причины его будут те же (см. *Колит хронический. Энтерит острый*). Причиной хронического энтерита могут быть также лямблии, обычно обитающие в верхней части кишечника.

**Симптомы и течение** сходны с хроническим колитом: поносы, но более редкие, чем при остром энтерите, имеющие характер бродильной диспепсии, пенистые испражнения со слизью и большим количеством непереваренной пищи, отходит большое количество газов; развивается метеоризм, который сильно беспокоит больных. Больные жалуются на тяжесть в животе, урчание и небольшие боли. Живот вздут, умеренно болезнен при пальпации.

**Лечение** см. *Колит хронический, Энтерит острый*.

**ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ (ULCUS VENTRICULI ET DUODENI).** Психические переживания, психические травмы и контузии играют большую роль в возникновении язвенной болезни.

Советский ученый акад. К. М. Быков на основании учения И. П. Павлова установил, что в возникновении язвенной болезни главную роль играет нарушение деятельности коры головного мозга. Перевозбуждение высших нервных центров (коры головного мозга) вызывает повышенную возбудимость вегетативной нервной системы, что приводит к сосудистым и мышечным спазмам желудка, которые ведут к нарушению питания стенки его. Нужно еще иметь в виду, что при расстройстве функции вегетативной нервной системы нарушается и трофика (питание) клеток и тканей. При этом уменьшаются защитные свойства слизистой оболочки, и кислое содержимое желудка начинает разъедать слизистую оболочку, вследствие чего образуется язва. Нерегулярное питание, грубая и трудно перевариваемая пища, алкоголь, курение (никотин) способствуют образованию язвы. Язва желудка иногда наблюдается у ослабленных и малокровных людей. Закупорка или сужение кровеносных сосудов желудка при эмболии или склерозе также может способствовать развитию язвы.

Язвы чаще образуются около выхода желудка (в пилорической части), по малой кривизне или в двенадцатиперстной кишке, причем они бывают разной величины. Язва имеет круглую форму и может проникать до мышечной и даже серозной оболочки.

**Симптомы и течение.** Основной симптом — сильная боль в виде приступов в подложечной области, часто отдающая в спину. Характерна периодичность болей. Боли возникают вскоре после приема (через  $\frac{1}{2}$ —1 час) или позже (через 2—3 часа) грубой, кислой, соленой и трудно перевариваемой пищи (жирное жареное мясо, сдобные пироги и пр.). При язве двенадцатиперстной кишки наблюдаются также голодные и ночные боли. Язва сопровождается воспалением слизистой оболочки желудка с отрыжкой, изжогой, тошнотой и рвотой. В большинстве случаев имеется повышенная кислотность. Характерна кровавая рвота. При небольших желудоч-

ных кровотечениях рвоты может не быть; тогда кровь поступает в кишечник, и ее можно обнаружить при химическом исследовании испражнений; при значительном количестве крови в кишечнике испражнения приобретают темный, дегтеобразный цвет. Продолжительные или обильные кровотечения вызывают общую слабость, малокровие, похудание. При значительном кровотечении (кровяной рвоте) могут наступить явления коллапса (резкий упадок сердечно-сосудистой деятельности); нитевидный пульс или полное его исчезновение, резкое побледнение покровов, похолодание конечностей. Точно определить наличие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки иногда можно только путем рентгеновского исследования, которое дает для язвы характерную нишу (контрастная масса заполняет углубление в слизистой желудка, образованное язвой).

Язвенная болезнь может протекать хронически, годами, несильно беспокоя больного; в некоторых случаях язвы зарубцовываются, но часто спустя даже несколько лет появляются вновь; в других случаях наблюдаются периодические ухудшения и улучшения в состоянии больного. Рубцы вызывают сужение привратника, что ведет к затруднению, а иногда и полному прекращению эвакуации пищи из желудка. При прободении язвы возникает острый гнойный перитонит.

**Распознавание.** Язвенную болезнь следует дифференцировать с другими желудочными заболеваниями (гастриты, ран желудка), а также заболеваниями соседних органов, сопровождающимися приступами резкой боли: холецистит, желчно-каменная болезнь, почечная колика, острый аппендицит, непроходимость кишечника, перитонит. Очень важное значение имеет язвенный анамнез.

**Лечение.** При острых явлениях язвенной болезни — покой (постельный режим) и диета. Ввиду того что в развитии язвенной болезни большую роль играет нервная система, нужно создать для таких больных спокойную обстановку, чтобы они не возбуждались и т. д.

Если больные слишком возбудимы, плохо спят, назначают средства, успокаивающие нервную систему (бромиды, люминал, бар-бамил и др.).

В развитии язвенной болезни первенствующую роль играет перевозбуждение центральной нервной системы. В связи с этим в последнее время с успехом проводят лечение длительным сном (см. *Гипнез > тоническая болезнь*). Стол должен быть механически и химически щадящим. Необходимо частое питание небольшими порциями (5—8 раз в день). Пища готовится исключительно в протертом или размолом виде с ограничением поваренной соли (соль повышает секрецию желудочного сока). Из пищи исключаются всякие пряности и приправы. Сначала дают молоко, сливки, сливочное масло, слизистые супы, яйца всмятку, кисели (некислые), протертые каши, затем прибавляют белые сухари, паровые котлеты, компоты из вареных протертых ягод и фруктов, затем — белый черствый хлеб, картофельное пюре, вареное и размоленное нежирное мясо или рыбу, вареные протертые овощи и фрукты. Постельный

режим продолжается в среднем 1—1V-2 месяца до тех пор, пока не пройдут острые явления. При болях — грелки, припарки, согревающие компрессы. При язвенной болезни применяют также тканевую терапию. Подсаживают обычно ткань яичка и селезенки.

Из лекарственных средств назначают атропин (белладонну), щелочи, висмут, азотнокислое серебро.

Вр. Sol Atropini sulfurici 0,1% 1,0 D. t. d.  
N. 6.in amp. S. По 0,5—1,0 на  
инъекцию

Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 15,0 DS. По  
5—10 капель 3 раза в день

Rp. Fxtr. Belladonnae 0,015 Natrii  
bicarbonici Magnesiaе ustae aa 0,5  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12 S. По 1  
порошку 3 раза в день

Rp. Bismuti subnitrici 1,0 D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3—  
4 раза в дспь перед едой

Rp. Sol. Argenti .nitrici ex 0,2—200,0  
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день за  $\frac{1}{4}$  часа до еды

Нельзя азотнокислое серебро давать продолжительное время (несколько месяцев), так как серебро откладывается в тканях и кожа на открытых частях тела приобретает серую окраску \* (аргироз).

При желудочном кровотечении (кровоавой рвоте или дегтеобразном стуле): абсолютный покой, на подложечную область пузырь со льдом; внутривенно хлористый кальций или хлористый натрий, подкожно нормальную лошадиную сыворотку (50 мл). При значительном кровотечении: переливание 100—200 мл крови, а иногда и больше; первые 1—2 дня больному не дают ни пить, ни есть; глюкоза — в небольших капельных клизмах или внутривенно; при сильной жажде — полоскать рот при условии обязательного выплевывания воды. После окончания кровотечения (или при его уменьшении) на 2—3-й день дают пищу только в холодном виде и небольшими порциями: сливки чайными ложками, кусочки сливочного масла (несоленого), яичные белки. Затем постепенно переходят к питанию, указанному выше.

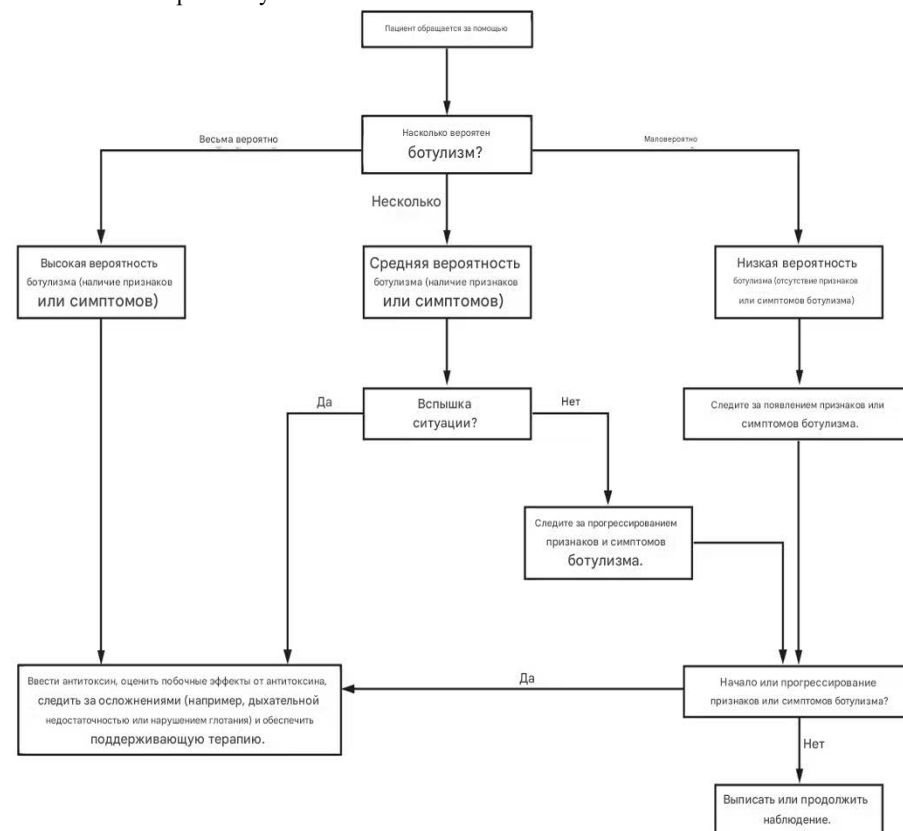
При хроническом течении язвы лечение приблизительно то же, что и при хроническом гастрите с повышенной кислотностью. Основой лечения продолжает оставаться соответствующая диета и определенный режим, щадящий нервную систему. Хорошее дейст-

вие оказывает курортное лечение в Железноводске, Ессентуках или Боржоми. Категорически запрещается курить и употреблять алкоголь. Если язва полностью зарубцуется и в течение года будут отсутствовать все клинические явления, можно переходить на общий режим.

К хирургическому лечению прибегают, когда повторное продолжительное лечение не оказывает действия и постоянные сильные боли истощают больных, а также при повторных кровотечениях и рубцовых сужениях привратника. В случае прободения язвы требуется срочная операция.

следующая тема Ботулизм ...

Оценка пациентов с известным или возможным воздействием ботулотоксина = эндотоксина в обычных и экстренных условиях



## ГЛАВА II

## ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

**БЕШЕНСТВО. ВОДОБОЯЗНЬ (BABIÉS).** Возбудитель-фильтрующий вирус. Инфекция передается укусом бешеных животных (собаки, кошки, волка, крысы), в слюне которых содержится вирус. В мозгу бешеных животных, особенно в клетках аммо-ниа рога, находят тельца Негри.

**Симптомы и течение.** Инкубация бешенства у человека 15—80 дней; иногда может затянуться до полугода и дольше. Болезнь имеет 3 периода. В начальном (предвестниковом) периоде (1—2 дня) появляется беспокойство, угнетенное состояние, бессонница и боли в месте укуса и по ходу близлежащих нервов. Второй период — возбуждение (длится 2—3 дня) выражается в резко повышенной чувствительности к малейшим внезапным раздражениям (шум, яркий свет, крик и др.); судороги мышц глотки при попытках к еде и питью и даже при виде пищи и воды, а также при малейшем стуже, дуновении воздуха и т. д.; появляются галлюцинации, бред, страх; больные становятся агрессивными, буйными. В третьем периоде развиваются параличи глазных мышц, пог и дыхания, наступает смерть. Все случаи типичного бешенства, заканчиваются смертью. См. гл. IV *Психические болезни, Психозы инфекционные*.

**Распознавание.** Помимо характерной возбудимости и быстро наступающих параличей, большое значение имеет наличие укуса или ослонение подозрительными на бешенство животными. Диагноз подтверждается исследованием мозга подозрительных на бешенство животных и нахождением в его клетках телец Негри. Необходимо исключить: белую горячку, где бред и зрительные галлюцинации занимают первое место в клинической картине болезни, столбняк и истерию, где затрудненное дыхание и судороги мышц глотки не являются ранними признаками болезни, как при бешенстве.

**Лечение.** Специфического лечения нет. Против мучительных судорог — клизмы из хлоралгидрата (3%) или смазывания зева 2% раствором новокаина.

Вр. Chlorali hydrati 3,0  
Dccocti amyli 100,0  
MDS. На 1 клизму

**Профилактика.** Борьба с бешенством среди животных, уничтожение бродячих собак, кошек и волков. Зараженными считаются лица: 1) укушенные бешеными или подо-

зрительными животными непосредственно или через одежду, даже при самых ничтожных травмах; 2) и с с а п а н - н ы е; 3) лица с попавшей на кожу или в глаз слюной бешеного животного или подозрительного на бешенство.

Подозрительными на бешенство животными считаются: 1) внезапно убежавшие из дома, 2) павшие во время наблюдения за ними, 3) убитые при нанесении ими укусов, 4) искушавшие многих лиц, 5) неизвестные. Люди, укушенные бешеными и подозрительными на бешенство животными, немедленно подвергаются специфическим пастеровским прививкам на пастеровских станциях или в медицинских учреждениях полученным отсюда прививочным материалом ежедневно под кожу живота от 15 до 25 дней подряд в зависимости от места укуса (в ногу или в лицо). Пастеровские прививки производятся эмульсией высушенного мозга, зараженного фиксированным вирусом кролика. Больные бешенством изолируются.

**БОЛЕЗНЬ БОТКИНА. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ** см. гл. 1 *Внутренние болезни, Болезнь Боткина*.

**БОТУЛИЗМ (BOTULISMUS).** Развивается от отравления ток-синами микроба *B. botulinus*. Загрязненные этим микробом консервы (мясные, рыбные и овощные), колбаса и красная рыба являются основными источником этого возбудителя.

**Симптомы и течение.** Инкубация от 2—3 часов до 1—2 дней. Характерные признаки: расширение зрачков, двоение и туман перед глазами, расстройство аккомодации (результат действия токсина на центральную нервную систему). Упорные запоры, часто не поддающиеся действию клизм и слабительных; рвота и поносы встречаются редко и кратковременны. В тяжелых случаях наступает расстройство глотания (паралич мягкого неба). Тоны сердца становятся глухими, пульс, вначале замедленный, начинает ускоряться, кровяное давление падает. Температура нормальная, сознание сохранено. Смерть может наступить быстро (в первые же сутки).

**Распознавание.** На основании ранних глазных признаков, связанных с употреблением подозрительных продуктов. Для уточнения диагноза производится лабораторное исследование остатков пищи, рвотных масс, испражнений, мочи и крови больных. Цитратная кровь и моча, исследуются лишь на наличие токсина, для чего вводятся в количестве 2 мл подкожно мышам. Остальной материал в стерильной посуде отправляется для посева в лабораторию.

**Лечение.** Немедленное прог(ывание желудка 5% содовым раствором независимо от давности отравления. Внутрь — оливковое масло (для связывания токсина), сифонные клизмы и самое главное — незамедлительное введение 40—80 мл противоботулиновой сыворотки [не менее 50 000—100 000 АЕ внутримышечно или внутривенно (20 мл) в течение 2—3 дней подряд]. Вливание физиологического раствора (500—600 мл) и стрихнин.

Вр. Sol. Stryctmini nitrici 0,1% 1,0  
Sterilisttur!  
D. t. d. N. 1 in ampullis DS. На  
1 инъекцию

**Профилактика.** Строгий санитарный надзор за консервным производством и за пищевой промышленностью вообще. Обязательно изъять из употребления в пищу вздутые консервные банки (бомбаж) и продукты, имеющие запах острого сыра или прогорклого масла.

**БРУЦЕЛЛЕЗ (BRUCELLOSIS).** Бруцеллез — болезнь домашнего крупного рогатого и мелкого скота, от которого люди заражаются при непосредственном соприкосновении с выделениями (кал, моча) больных животных (ветеринарные работники, ухаживающий персонал, доярки и др.) или при употреблении зараженных пищевых продуктов от больных овец, коров и свиней (молоко, творог, брынза и т. д.). Возбудитель — бруцеллы (*Brucella meli-lensis*, *Brucella abortis bovis*, *Brucella abortis suis*).

**Симптомы и течение.** Инкубация около 14 дней. Обычно болезнь начинается постепенно следующими признаками: волнообразная (типичный признак), иногда перемежающаяся лихорадка, жалобы на боли в суставах, мышцах и по ходу нервов, обильное потение.

Эти признаки принимают часто затяжной характер и протекают волнообразно в виде длительных обострений. Лихорадочные приступы могут длиться от 3 до 5 недель и больше и болезнь затягивается на годы. Часто отмечается увеличение селезенки и печени. Сердечно-сосудистая система мало поражается, хотя иногда встречаются специфические эндокардиты. В легких — нередко изменения, напоминающие туберкулезные. Различные невралгические боли, ишиас, радикулит и др. У мужчин нередко орхиты, эпидидимиты; у женщин — аднекситы, эндометриты, самопроизвольные выкидыши, маститы. Со стороны крови — анемия, лейкопения с лимфоцитозом, моноцитоз. На коже — иногда различного характера сыпь.

**Распознавание.** Анамнез (соприкосновение с больными животными, употребление в пищу подозрительных продуктов) и клинические характерные признаки. Для подтверждения диагноза делаются реакции: реакция агглютинации Райта с сывороткой больных бруцеллезным антигеном, причем положительной считается реакция в разведении не ниже 1 : 200—1 : 400; упрощенная реакция агглютинации Хеддльсона на стекле со специальным для этой реакции антигеном; реакция Бюрне — аллергическая проба с мели-тином, для чего внутрикожно вводится 0,1 мл реактива; положительной проба считается тогда, когда через 18—24 часа на месте впрыскивания образуется покраснение и инфильтрат.

Бруцеллез следует отличать от рецидивов брюшного тифа (где имеется ясно выраженное тифозное состояние, отсутствующее при бруцеллезе), от ревматизма (опухли суставов и поражение с рдца — миокарда и клапанов), от малярии (наличие ежедневных приступов, исследование толстой капли крови помогают выяснить диагноз малярии), от приступов возвратного тифа.

**Лечение** специфическое. Внутривенные (или подкожные) впрыскивания нарастающих доз бруцеллезной вакцины (3—5—10—15—20—40—75 млн. и т. д. тел убитых микробов) с промежутками в 3—5 дней между каждым впрыскиванием. Введение вакцины

каждый раз сопровождается подъемом температуры до 39° (реакция на введенный бруцеллезный антиген); при бурной реакции во время следующего впрыскивания доза вакцины не попытается. Большое значение имеет, особенно при хроническом течении бо-, лезни, физиотерапия (кварц, диатермия, облучение селезенки рентгеновыми лучами, грязелечение и др.). В острой стадии рекомендуется стрептоцид в больших дозах (3 г в сутки) равными частями через 3 часа.

**Профилактика.** Изоляция больных бруцеллезом животных и защита лиц, ухаживающих за ними (дезинфекция рук, спецодежда, резиновые перчатки). Строгий санитарный надзор на заводах молочных продуктов (пастеризованное молоко, брынза выдерживается до 60 дней). Мясо в вареном виде не заразно, но во время приготовления мясных блюд из зараженного мяса можно заразиться (прием пищи загрязненными руками или через поврежденную кожу). Изоляция больных людей в острой стадии; заливка 10% хлорной известью или 5% лизолом их выделений (мочи и кала). На работу в молочных хозяйствах переболевшие допускаются через 2 месяца после исчезновения у них клинических проявлений болезни.

**БРЮШНОЙ ТИФ (TYPHUS ABDOMINALIS).** Возбудитель — подвижная, снабженная жгутиками брюшнотифозная палочка. У больного брюшным тифом ее можно высеять из крови, 1 ша и мочи. Главный источник распространения — брюшнотифозные больные и переболевшие брюшным тифом (бациллоносители), нередко и здоровые бациллоносители. От них палочки брюшного тифа могут заноситься в пищевые продукты и в воду грязными руками, калом и мочой, мухами. Брюшнотифозные палочки проникают в лимфо-идный аппарат главным образом тонкой кишки — солитарные фолликулы, пейеровы бляшки, мезентериальные железы, — размножаются здесь и попадают в ток крови, разносясь ею по всему организму.

**Симптомы и течение.** Основные признаки: постепенное развитие лихорадки, часто достигающей высоких цифр; она длится в типичных случаях около 4—5 недель и постепенно снижается, давая к концу часто большие размах кривой. Чем тяжелее протекает болезнь, тем менее выражены колебания утренней и вечерней температуры. На 8—9-й день болезни появляется сыпь в виде розеол, чаще на животе у реберных дуг. Розеола возвышенная, легко исчезающая при надавливании. К этому же времени прощупывается увеличенная селезенка средней плотности, нередко и печень. Пульс отстает от температуры. В крови — уменьшенное количество лейкоцитов (лейкопения). Сознание затемнено. Язык обложен в центре густым коричневатым налетом, края и кончик его красные. Живот слегка напряжен и болезнен в правой подвздошной области, урчание в области слепой кишки. Часто наклонность к запорам; если бывает жидкий стул, то он по виду напоминает гороховый суп. Тоны сердца глухие, пульс дикротичный. Часто бронхит или бронхопневмония. Головная боль и бессонница, в тяжелых случаях менингеальные явления (ригидность затылка, положительный симптом Кернига); реже. — возбужденное состояние,

Сопровождающееся иногда бредом или галлюцинациями. См. гл. IV *Психические болезни, Инфекционные психозы.*

С третьей недели болезни возможны кишечные кровотечения или прободения язв, имеющих в тонкой кишке. При этом развивается картина острого живота (острая боль в правой подвздошной области, напряжение и вздутие живота, исчезновение печеночной тупости, учащение пульса, западение черт лица). Другие осложнения: воспаление среднего уха и околоушной железы (паротит), воспаление вен (тромбофлебиты), чаще на нижних конечностях, кожные нарывы, омертвления.

**Р а с п о з н а в а н и е .** - Диагноз ставится на основании типичных признаков: длительная лихорадка, увеличение селезенки, отставание пульса от температуры, розеола, расстройство кишечника, тифозное состояние, лейкопения. Посев 5—10 мл крови (для ранней диагностики) на среду с бычьей желчью (50—100 мл среды) и реакция Видала (с кровью больного, взятой из мякоти пальцев в количестве 1,5—2 мл). Реакция агглютинации Видала получается чаще с 11-го дня болезни. Надо помнить, что положительный результат реакции может получаться в небольших разведениях (1 : 100—1 : 200) и у здоровых людей, особенно у привитых, поэтому надо считаться с нарастанием титра агглютинации или с большими разведениями (1 : 800 и выше).

Дифференцировать брюшной тиф приходится: от милиарного туберкулеза (для которого характерны одышка и цианоз), от сыпного тифа (ранняя на 4—6-й день петехиальная сыпь), от возвратного тифа (потрясающий озноб и резкие боли в икроножных мышцах), от гриппа (катарры верхних дыхательных путей, герпес), от сепсиса (скачущая температура, ознобы и поты).

**Л е ч е н и е .** Главным образом симптоматическое. Специфическое лечение тифозным бактериофагом (по 50 мл) с помощью дуоденального зонда ежедневно в течение 3 дней. Лекарственные средства: при выраженной интоксикации — внутривенно 40% раствор глюкозы по 20—30 мл ежедневно или 5% раствор глюкозы на физиологическом растворе под кожу в количестве 30—400 мл. При ослаблении сердечной деятельности — камфора 20% по 1—2 мл или кофеин по 1 мл под кожу; при кишечных кровотечениях — полный покой, внутривенное вливание 10 мл 10% раствора хлористого кальция; 20—30 мл нормальной лошадиной сыворотки внутримышечно; инъекции под кожу атропина (1 : 1 000) по 0,5—1 мл. При пневмонии — сульфаниламидные препараты, пенициллин. При прободении кишки — немедленное хирургическое вмешательство.

Особенное значение имеет правильный уход за больным: обтирание кожи камфорным спиртом, промывание полости рта 2% раствором борной кислоты, поворачивание больного, обильное питье. Питание — полноценное, щадящее, не вызывающее механического раздражения кишечника (протертые супы, бульоны, пюре, протертые молочные каши со сливочным маслом, сливки, молоко, простокваша, протертое мясо, яйца всмятку, белые сухари, фруктовые, ягодные и овощные соки). При кишечных кровотечениях питание резко ограничивается или совершенно прекращается на 1—2 дня. В последнее время с хорошим результатом применяется новый

антибиотик — левомицетин; подробно см. гл. XVII *Фармакологические сведения, Левомицетин.*

**П р о ф и л а к т и к а .** Раннее выявление больных и их изоляция, дезинфекция помещения, текущая дезинфекция у постели больного (испражнения перед выливанием в уборную заливаются на 1—2 часа 10% раствором хлорной извести, или 5% раствором лизола, или 3% раствором хлорамина); грязное белье замачивают перед стиркой в течение 2 часов в 1% растворе хлорамина или в 3% растворе лизола, или мыльно-карболовом растворе. Посуда больного после употребления кипятится. Борьба с мухами; защита ■ищи и продуктов \*от мух, систематический санитарный надзор за бациллоносителями. Недопущение бациллоносителей к работе в пищевых учреждениях и на водопроводе, если они соприкасаются с пищевыми продуктами и водой водохранилища. Двукратное исследование кала и мочи, (на выделение бацилл) больных перед их выпиской из больницы. Прививки против брюшного тифа: брюшнотифозная вакцина вводится одновременно с паратифозной {А и Б) под кожу 3 раза в дозах 0,5—1—1 мл с промежутками, в 5—7 дней.

**ВОЗВРАТНЫЙ ТИФ (TYPHUS RECURRENS).** Различают два вида возвратного тифа: эпидемический европейский (вшиный) и эндемический (клещевой африканский, среднеазиатский, американский и т. д.). Возбудитель европейского возвратного тифа — спирохета Обермейера. Инфекция передается от больного человека через вошь, главным образом платяную. Возбудитель среднеазиатского возвратного тифа — спирохета Sogdiana, а источник инфекции — грызуны, от которых она передается человеку через клещей (путем укуса последних).

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Характерный клипический признак — приступообразное течение с 1 0, период лихорадочного тифоподобного состояния сменяется безлихорадочным периодом, за которым наступает в большинстве случаев новый лихорадочный период. Инкубация 5—7 дней. Болезнь начинается внезапно ознобом и головной болью, болью в икроножных мышцах. Температура высокая (выше 40°) при европейском тифе и умеренная — при среднеазиатском. Лихорадка протекает приступами: при европейском тифе первый приступ длится 5—7 дней и быстро (критически) надает при проливном: поте. Затем наступает безлихорадочный период, длящийся около 8—10 дней, и так же внезапно наступает второй присту\*. В среднем бывает. 3—4 приступа и промежутки между ними правильно увеличиваются (до 21 дня), а лихорадочный период укорачивается (до 1—2 дней). При клещевом тифе лет этой правильности в чередовании приступов и число их больше (10—15). Кожа и склеры (белочные оболочки глаз) часто имеют желтушную окраску. Часты носовые кровотечения. Селезенка делается плотной, большой и болезненной. Увеличивается также часто и печень. В крови при европейском тифе — лейкоцитоз, при клещевом »\* лейкопения. Осложнения: нередко желчный тифоид — желтуха интенсивно шафранового оттенка, склонность к кровотечениям, (геморрагическая сыпь на коже), гематурия (мочекровие), кровавый понос и рвота; геморрагический сепсис. Смертность при

осложнениях выше 60%; нередко встречаются аборт, инфаркты селезенки и поражение сосудистой оболочки глаза (ириты, иридоциклиты).

**Р а с п о з н а в а н и е .** Спирохета может быть найдена у человека в первый же день болезни и до падения температуры в мазках крови или еще лучше в толстой капле.

У каждого остролихорадящего больного необходимо брать толстую каплю, чтобы не пропустить приступа возвратного тифа.

Дифференцировать приходится в первые дни болезни от брюшного и сыпного тифа, гриппа, пневмонии. От них возвратный тиф отличается наличием болей в икроножных мышцах, ранним увеличением селезенки; от малярии — длительностью приступов.

**Л е ч е н и е .** Специфическое: поварсенолом (неосальварсаном) в дозе 0,6 (из расчета 0,01 на 1 кг веса) внутривенно, предпочтительно на 4—5-й день первой атипичии (период, когда температура держится ниже нормы); при клещевом тифе лучше внутримышечные инъекции миарсенола по 0,3 г три дня подряд или осарсол внутрь по 0,25 четыре раза в день в течение 3—4 дней. Такой курс лечения осарсолом повторяется с промежутками 2—3 раза.

При кровотечениях хорошо действуют внутривенные вливания по 10 мл 10% хлористого кальция."

**П р о ф и л а к т и к а .** При европейском возвратном тифе — раннее помещение в больницу, борьба со вшивостью. При среднеазиатском — борьба с грызунами, с клещами (очистка помещений от клещей); пропитывание белья и спальных принадлежностей 3% эмульсией мыла К и другими средствами.

**ГАЗОВАЯ ГАНГРЕНА** см. гл. VI *Хирургические болезни.*

**ГРИПП (GRIPPUS).** Возбудитель — фильтрующий вирус. Источник инфекции — больной человек, от которого возбудитель передается капельным путем. Часто встречающийся сезонный грипп (или инфлюэнца) вызывается палочкой Пфейффера или пневмококками, стрептококками, стафилококками и др.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Инкубация — от > до 3 дней. Головная боль, насморк, конъюнктивит, сухой короткий кашель при воспалительных явлениях в гортани, дыхательном горле и бронхах. Температура неопределенная (от субфебрильной до высокой); длительность лихорадки от 1—2 до 7—8 дней. Катарры дыхательных путей, глаз при эпидемическом гриппе развиваются лишь через некоторое время и сопровождаются явлениями общей интоксикации (разбитость, общая слабость). При сезонном гриппе катарральные явления выражены с самого начала болезни и иногда предшествуют развитию лихорадки, общее состояние менее нарушено.

Частое осложнение — гриппозная бронхопневмония — с кровоизлияниями (кровавая мокрота, носовые кровотечения). Грипп осложняется также воспалениями среднего уха, лобных и гайморовых пазух. Кроме катарральной формы гриппа, различают еще нервную форму с явлениями невритов, менинго-энцефалита. У детей часто встречается желудочно-кишечная форма.

Грипп отличается: а) от начальных стадий брюшного, сыпного и возвратного тифа катарральными явлениями, непродолжитель-

ностью болезни (не более 7 дней); б) от болезни паппатачи — отсутствием глазных признаков Пика и Тауссига.

**Л е ч е н и е .** Уротропин по 0,5 г 3 раза в день, кальцекокс по 0,5 по 1 таблетке 3 раза в день. Стрептоцид по 0,5 г 3 раза в день, сульфидин, норсульфазол по 0,5 г 3 раза в день. При осложнениях пневмонией, менинго-энцефалитами (см. соответствующие болезни).

**П р о ф и л а к т и к а .** Изоляция первых случаев (помещение в больницу, на дому — ширмами, марлевыми масками для кормящих матерей). Мытье рук, пользование отдельным полотенцем, посуды. Влажная ежедневная уборка помещения 0,2% раствором хлорной извести.

Для профилактики гриппа (вирусного, эпидемического) используется экомлин в неразведенном виде, путем капельного введения в каждую ноздрю в количестве 4 капель, или путем распыления с помощью специальных пульверизаторов (доза 0,5 мл). Для детей доза экомлина уменьшается в два раза.

Препарат вводят при соответствующих эпидемиологических показателях повторно через каждые 3—4 дня и не позднее 5-го дня со времени первого введения, вплоть до окончания вспышки (повышенной заболеваемости) в данном коллективе. При повторном введении доза остается той же.

Лечебное применение экомлина при вирусном гриппе осуществляется следующим образом: при наличии катарральных явлений в верхних дыхательных путях препарат применяется в виде закапываний по 4—6 капель в каждый носовой ход 3 раза в день или в виде ингаляций. При более тяжелой форме гриппа препарат вводят одновременно внутримышечно по 1 мл 1—2 раза в день.

При осложненном эпидемическом гриппе экомлин следует сочетать с пенициллином как для местного, так и для общего действия (аэрозоль раствора, капли, порошки, таблетки и внутримышечное введение).

Для борьбы с острым сезонным катарром верхних дыхательных путей такие рекомендуются применение комбинированных препаратов: закапывание в нос или распыление пенициллина с экомлином и пеницилин-экомлиновые лепешки (таблетки для сосания) (З. В. Брюльева).

**ДИЗЕНТЕРИЯ АМЕБНАЯ (AMOEBIASIS).** Возбудитель — дизентерийная амeba (Entamoeba histolytica), встречающаяся в виде двух форм — вегетативной, быстро погибающей вне организма, и цисты, сохраняющей стойкость во внешней среде. Источник инфекции — больной человек. Дизентерийных амeb находят в свежих теплых испражнениях больного. Болезнь передается через загрязненную руками или мухами пищу и через воду, загрязненную калом больных. Амeбы гнездятся в толстой кишке, образуя на слизистой глубокие язвы с подрытыми краями.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Вначале понос в виде жидких испражнений; через несколько дней кал принимает типичный вид малинового желе (стекловидная слизь, густо перемешанная с кровью), появляются явления со спазмообразными болями по ходу толстой кишки, главным образом справа. Инкубация в среднем

7—14 дней. Болезнь часто течет хронически, давая обострения, и ведет к истощению.

Осложнения: гнойник печени, дающий нередко метастазы в легкие и мозг; прободной перитонит, кишечные кровотечения и сужения.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Нахождение (под микроскопом) дизентерийной амебы в испражнениях. При ректороманоскопии можно обнаружить типичные кратерообразные язвы на слизистой толстой кишки.

**Л е ч е н и е .** Специфическое — раннее введение 2% эметина по 1—2 мл 2 раза в день внутримышечно в течение 6 дней. Проводятся 2—3 курса с перерывом в 6 дней.

Через 2 месяца рекомендуется провести таких же 2—3 курса лечения эметинном. Хорошо действует также иатрен — внутрь по 0,25 4 раза в день в течение 8 дней или в виде клизм из 3% раствора патрона по 50 мл. Курс лечения иатреном обычно чередуется с курсом лечения эметинном. Осарсол внутрь по 0,25 4 раза в день натощак в течение 5 дней; 3—5 курсов с пятидневными перерывами между ними.

Rp. Pol. Emetini hydrochlorici 2% 1,0  
Sterilisetur! in ampullis DS. На 1  
инъекцию 1—2 мл

Дизта см. *Дизентерия бациллярная*.

**П р о ф и л а к т и к а .** Санитарно-гигиенический надзор, как при бациллярной дизентерии; строгий учет цистоосителей и их систематическое лечение.

**ДИЗЕНТЕРИЯ БАЦИЛЛЯРНАЯ (DYSENTERIA BACILLARIS).** Возбудитель — бациллы Григорьева — Шига-Крузе, бациллы группы Гисс-Флекснера, Шмитц-Штуцера, Зонье. Источник инфекции — больной острой или хронической формой дизентерии и бациллоноситель. Путь заражения — загрязнение каловыми массами больного пищевых продуктов, главным образом через мух или грязными руками, возможен и водный путь заражения.

Дизентерийные микробы гнездятся главным образом, в толстой кишке, вызывая своими токсинами на слизистой кишки фибринозное воспаление и поверхностные ссадины и язвы. У больного можно выделить дизентерийных микробов из свежих испражнений, а еще лучше забирать материал для посева непосредственно из прямой кишки стеклянной трубкой или тампоном по время ректоскопии.

**С им п то м ы и т е ч е н и е .** Инкубация 3—6 дней. Схваткообразные боли по ходу толстой кишки, частые позывы на низ — жидкие с выделением небольших количеств слизисто-кровянистых испражнений, впоследствии с примесью гноя и ключев отторгнувшейся слизистой оболочки кишки. Сигмовидная кишка прощупывается в виде толстого жгута, болезненного наощупь. Температура повышенная или субфебрильная и даже нормальная, независимо от тяжести процесса. В тяжелых случаях появляется резкая общая слабость, падает кровяное давление, пульс делается частым, мягким. Язык обложен сероватым налетом, живот втянут. Осложнения: бронхопневмония, особенно у детей и стариков, воспаление среднего уха, воспаление суставов, выпадение прямой кишки.

Болезнь в 10% случаев переходит в хроническую форму, преимущественно у лиц с пониженной сопротивляемостью организма, а также в результате несвоевременного и неправильного лечения острых форм дизентерии. При хронической дизентерии периоды улучшения кишечных расстройств чередуются с повторяющимися обострениями.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Бактериологическое исследование кала больных; реакция агглютинации крови или фильтрата каловых масс по Нредтеченскому. Микроскопическое исследование кала на наличие лейкоцитов, эпителиальных клеток, эритроцитов и слизи и реакция Трибуле (на наличие в кале воспалительных белков).

При ректороманоскопии можно обнаружить дизентерийные изменения на слизистой нижнего отрезка толстой кишки (гиперемия, язвы) даже при оформленном стуле.

Исключаются: 1) амёбная дизентерия (характер стула — малиновое желе, уплотнение и болезненность области слепой кишки и нахождение амёб или их цист в кале); 2) дизентерийноподобные осложнения при уремии, сепсисе, отравлениях сулемой. Ректоро-маноскопия облегчает диагноз.

**Л е ч е н и е**<sup>1</sup>. Раннее и активное лечебное вмешательство обеспечивает успех и предупреждает переход острой формы дизентерии в хроническую.

При строгом соблюдении индивидуального подхода (возраст общее состояние и т. д.) к каждому дизентерийному больному современное лечение в принципе должно быть всегда ранним, активным и комплексным. Кроме того, лечение это схематически подразделяется на специфическое и неспецифическое и проводится с обязательным учетом формы, фазы и тяжести течения болезни. Лечение дизентерийных больных важно начинать немедленно с момента их выявления. Лечение необходимо сочетать с проведением на месте первичных противозидемических мероприятий (первичная бытовая изоляция заболевших, возможно более быстрая их госпитализация, надлежащая дезинфекция в очаге и т. п.) При проведении специфического лечения дизентерийных больных должны быть использованы: химиотерапия (сульфаниламидные препараты), серотерапия, бактериофаготерапия; реже применяется вакциноотерапия. Из других лечебных методов практически важны: симптоматическое лечение, лечебное питание и методы, влияющие на общую реактивность организма.

Из химиотерапевтических средств, испытанных при лечении дизентерийных больных, наиболее широко применяется сульфазол, дисульфам, сульфатиазол и др. Эти препараты действуют главным образом бактериостатически. Основным методом введения сульфаниламидных препаратов при лечении дизентерийных больных является пероральный (через рот), который имеет преимущественное применение над остальными (внутривенный, внутримышечный и др.). Последние сохраняют свое значение лишь при наличии определенных показаний (рвота и др.). Эффективность химиотерапевтического

<sup>1</sup> Лечение дизентерии составлено применительно к официальным материалам Министерства здравоохранения СССР Г. И. Жуковым.



действия различных сульфамидных препаратов при дизентерии связана не только с их фармакологическими способностями (свойствами), но и с дозировкой, способами введения, а также со сроками применения, что является особенно практически важным. При приемах сульфаниламидных препаратов назначают обильное питье, так как при выделении их через мочевые пути могут образоваться конкременты, наблюдаться гематурия и даже анурия. При оценке лечебного действия сульфаниламидных препаратов приходится учитывать и их возможное побочное действие, преимущественно первично токсического характера (тошнота, рвота и пр.). Терапевтический эффект при лечении сульфаниламидными препаратами возможен при достаточной концентрации препарата в крови. Вследствие довольно быстрого выведения сульфаниламидных препаратов из организма необходимы регулярные приемы их для поддержания соответствующей концентрации (концентрация в крови должна быть равна 0,005 мг%). Сульфотерапия наиболее эффективна при раннем ее применении.

Ориентировочная схема лечения сульфаниламидами (сульфазол, дисульфан и др.) взрослых больных:

Первый день лечения по 1 г через каждые 4 часа, при этом на первый прием можно дать 2 г, т. е. по 6—7 г за сутки.

Второй день лечения по 1 г через каждые 4 часа

|                        |   |                               |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Третий день лечения    | 1 | по 1 г через каждые 6 часов   |
| Четвертый день лечения | / | по 4 г за сутки               |
| Пятый день лечения     | 1 | по 0,5 г через каждые 6 часов |
| Шестой день лечения    | ) | по 2 г за сутки               |

Всего на курс лечения — 24–25 г

Приведенная схема является лишь ориентировочной. Как правило, лечение должно назначаться индивидуально, в зависимости от состояния больного. При недостаточном терапевтическом эффекте полного курса лечение должно быть продолжено. Сульфаниламидотерапию следует сочетать с постельным режимом, соответствующей диетой, общим уходом.

За последнее время выяснено, что хотя сульфаниламидотерапия приводит обычно (и чем раньше начато лечение, тем скорее) к ослаблению клинических проявлений дизентерии и их прекращению, такое клиническое улучшение не совпадает с анатомическим восстановительным процессом, что легко подтвердить ректороманоскопией. Вот почему нередко приходится проводить сульфаниламидотерапию в дальнейшем повторно, в частности, при рецидивах, обострениях и т. п.

При токсической форме дизентерии показано проведение серотерапии. Сыворотку вводят внутримышечно от 50 000—100 000 до 150 000 АЕ с предварительной десенсибилизацией по Везредке (под кожу 0,5—1 мл сыворотки за 2 часа до введения всей лечебной дозы). При показаниях сыворотку вводят повторно через 24—48 часов в той же или половинной дозе. Считается, что серотерапия наиболее эффективна в самом начале болезни; позже четвертого дня болезни сыворотку обычно не назначают. Серотерапию комбини-

руют с лечением сульфаниламидными препаратами в зависимости от состояния больного.

Противодизентерийный поливалентный бактериофаг наиболее эффективен при раннем выявлении заболевших и дается в этот же день через рот взрослым в дозе 25—35 мл на щелочной воде. Повторно бактериофаг принимают в этом же количестве спустя 24 и 48 часов. В случае с отрицательным результатом лечение бактериофагом прекращается. Фаг надо давать натощак или через 4 часа после еды. При фаготерапии назначение слабительных не показано. При самых легких формах дизентерии лечение может иногда ограничиться только фаготерапией. При более тяжелом течении болезни фаготерапия сочетается с другими методами и средствами.

В качестве стимулирующей терапии применяют переливание крови, обычно дробными дозами (по 100—150 мл через 2—3—4 дня, всего до 5 вливаний и более). Предпочтительно не только введение крови (иногда рекомендуют не цельную кровь а разведенную физиологическим раствором в отношении 1 : 1), но и плазмы (до 80—100 мл, повторяя через день-два). Эти виды лечения особенно показаны при затяжной хронической дизентерии с тяжелым и среднетяжелым течением, а также при сочетаниях дизентерии с алиментарной дистрофией.

Солевые слабительные (избегать при приемах сульфамидных препаратов) назначают в виде 1—2% раствора сернокислой магнезии или сернокислого натрия до 1 л в сутки как питье. Применение их следует прекратить при наступлении улучшения со стороны кишечника. Изнуренным больным солевых слабительных назначать не следует.

Для местного воздействия применяют также (чаще в хронических случаях) клизмы из марганцовокислого калия (по 150 мл из баллона в разведении 1 : 5 000 или 1 : 3 000). Можно назначать также клизмы из раствора азотнокислого серебра 1 : 10 000 или риванола 1 : 1 000 тоже по 150 мл. Растворы вводят ледяными (до 40°) и после предварительной обычной клизмы. Показано обильное теплое питье и грелка или компресс на живот.

При проведении симптоматической терапии рекомендуется обезболивание и антисептические вещества: белладонна внутрь или атропин подкожно; по мере надобности —сердечные (кофеин, стрихнин, строфант, камфора и др.).

При отсутствии эффекта от сульфаниламидной терапии при острой дизентерии (когда по окончании курса лечения сульфаниламидами остаются еще патологические изменения в кишках, обнаруживаемые при контрольной ректороманоскопии), при упорном выделении возбудителей и при хронической дизентерии лечебный эффект (клиническое выздоровление, исчезновение патологических изменений на слизистой кишки и бактериологическая санация) дает лечение чесноком в виде чесночных клизм.

Техника приготовления клизм: 5 г чеснока растирают на мелкой овальной терке или пестиком в фарфоровой ступке, или ложкой в тарелке, добавляют 100 мл кипяченой воды, теплой или комнатной температуры и настаивают в закрытом сосуде в течение 1—2 часов.

Полученную смесь можно употреблять в течение 24 часов. Предварительно нагретая в теплой воде с температурой около 38°, взвесь вводится в прямую кишку резиновым баллоном.

При наличии оформленного кала делают предварительно очистительную клизму. Но, если за несколько часов до чесночной клизмы больной имел стул, очистительная клизма не нужна.

Во избежание раздражения сфинктера взвесь вводится через резиновую или Су (взрослых) стеклянную трубку, предварительно надетую на баллончик, на глубину 4—5 см. Клизмы ставятся ежедневно. В среднем на курс лечения требуется 10 клизм, но в упорных случаях болезни — до 15 и даже до 20 клизм.

Если приходится одновременно ставить клизмы многим больным, можно готовить взвесь, пропуская чеснок дважды через мясорубку, и затем дополнительно растирать его.

После первых чесночных клизм у некоторых больных наблюдается усиление выделения слизи и даже крови. На это надо смотреть не как на обострение процесса, а как на результат очищения слизистой кишечника.

Особо подчеркивается целесообразность назначения витаминных препаратов (аскорбиновая и никотиновая кислота, витамин В<sub>2</sub>), а также рациональной диетотерапии (полноценная и легко усваиваемая пища). Для лучшего пищеварения назначают соляную кислоту, пепсин, панкреатин.

Большое значение при лечении дизентерийных больных имеет лечебное питание. В пищевом рационе дизентерийного больного должно содержаться достаточное количество углеводов и белков, в то время как жиры следует ограничить. Дизентерийному больному рекомендуется вводить значительное количество жидкости как с целью предупреждения эксикоза, так и выведения токсических веществ.

При продолжительном выделении дизентерийных бактерий, но стойком отсутствии клинических проявлений болезни, выздоравливающие выписываются и передаются на особый учет и для наблюдения фельдшерам, участковым врачам, районным эпидемиологам и должны подвергнуться лечению чесночными клизмами.

Дизентерийные реконвалесценты как взрослые, так и дети выписываются из больницы после 2—3 отрицательных бактериологических исследований испражнений на наличие дизентерийных микробов. Кроме того, необходимо учитывать данные ректороманоскопии и копрологического исследований. Первое контрольное бактериологическое исследование производится после клинического выздоровления. В случаях невозможности проведения бактериологического и копрологического исследования выписка дизентерийных реконвалесцентов допускается не ранее 10 дней после клинического выздоровления.

Весьма целесообразно иметь на персональном учете также всех перенесших дизентерию в течение ближайшего года и установить за ними контроль с проведением бактериологических исследований. Этот метод позволяет выявить скрытых носителей больных хронической дизентерией, подвергнуть их лечению и этим предотвратить возможность появления новых вспышек заболеваний.

**Лечение детей.** Сульфаниламидные препараты применяются у детей до 3 лет из расчета 0,2 г на 1 кг веса в день; суточная доза делится на 6 приемов, препарат дается через 4 часа (иногда назначают в день 5 приемов, оставляя ночной промежуток в 8 часов). Курс лечения — 7—10 дней.

Ввиду наличия сульфаниламидоустойчивых штаммов дизентерийных микробов следует при отсутствии эффекта после 3—4 дней применения препарата заменять один сульфаниламидный препарат другим.

Следует иметь в виду побочное действие сульфаниламидных препаратов, выражающееся в появлении рвоты, цианоза, беспокойства, иногда сыпей лейко- и нейтропении. Побочное действие наблюдается у отдельных детей и чаще возникает при длительном применении препарата.

При наличии упорной рвоты, вызываемой иногда введением сульфаниламидных препаратов через рот, можно применять их внутримышечно в виде 10% раствора натриевой соли норсульфазола из расчета 0,2 мл раствора на 1 кг веса на одну инъекцию. Парентеральное введение проводится в течение 3 дней по 3—4 инъекции в день. Необходимо пользоваться разными иглами при набирании препарата в шприц и при введении его больному; рекомендуется заканчивать инъекцию добавлением физиологического стерильного раствора (1—2 мл), вводимого через ту же иглу.

Пенициллин применяется для лечения осложнений (отиты, мастоидиты, пневмонии) в течение 7—10 дней в дозировке до 100 000 единиц в день.

Синтомицин — новый антибиотик, полученный советскими учеными синтетическим путем. Кристаллический порошок белого цвета с желтоватым или зеленоватым оттенком, интенсивно горького вкуса, стабилен при обычном хранении и к нагреванию в нейтральных растворах.

Растворимость: хорошо — в спирту, метаноле и ацетоне, умеренно — в пропиленгликоле, слабо — в воде, почти нерастворим в углеводородах и эфире.

Синтомицин обладает высоким химиотерапевтическим действием при лечении бациллярной дизентерии и токсической диспепсии.

При лечении дизентерии и токсической диспепсии синтомицин применяется внутрь, желателно перед едой, детям в сахарном сиропе или с глюкозой, а также в виде свечей.

Лечение синтомицином должно начинаться немедленно по установленной диагноза до госпитализации больного, на дому, в поликлинике или в консультации.

Дача препарата в острых случаях начинается с ударной дозы (см. ниже) и производится только врачом и средним медицинским персоналом, перепоручение дачи препарата другим лицам не допускается.

Детям весом до 16 кг ударная доза препарата дается в два приема с промежутком в 1 час, которая равняется суточной дозе. Последующие дачи препарата производятся из расчета по 0,2 г на 1 кг веса па один прием 4—6 раз в сутки (каждые 4—6 часов) в течение 7—10 дней (см. схему).

При затяжной и хронической форме дизентерии у детей с весом до 16 кг синтомицин назначается без предварительной ударной дозы по 0,3 г на 1 кг веса на один прием 4 раза в сутки в течение 7—10 дней.

Детям весом более 16 кг и до 14 лет ударная доза препарата составляет 0,5—1 г и дается в два приема с промежутком в 1 час по 0,25—0,5 г на прием.

Последующие дозы препарата производятся не по весу, а в дозе 0,2—0,4 г на один прием 4—6 раз в сутки в течение 7 дней.

При затяжной и хронической форме дизентерии у детей весом более 16 кг и до 14 лет синтомицин назначается без предварительной ударной дозы по 0,25—0,4 г на один прием 4 раза в сутки в течение 7—10 дней.

Для детей в возрасте 14—16 лет ударная доза синтомицина составляет 1—2 г, которая дается в два приема с промежутком в 1 час по 0,5—1 г на прием.

Последующие дозы препарата производятся в дозе 0,3—0,5 г 4—5 раз в сутки в течение 7 дней.

При затяжной и хронической форме дизентерии у детей старшего возраста синтомицин назначается без предварительной ударной дозы по 0,3—0,6 г на один прием 4 раза в сутки в течение 7—10 дней.

В случае рецидива дизентерийного заболевания следует провести повторный курс лечения по нижеуказанной схеме, без применения ударной дозы.

Примерный расчет доз синтомицина при лечении острой дизентерии и токсической диспепсии у детей весом до 16 кг (для облегчения работы аптеки и больничного персонала дозы округлены).

| Вес ребенка<br>в кг | Разовая<br>доза | Суточная<br>доза | Ударная доза         |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 3                   | 0,06            | 0,36             | 0,2 через 4 часа 0,2 |
| 4                   | 0,08            | 0,48             | 0,25 » » 0,25        |
| 5                   | 0,1             | 0,6              | 0,3 » » 0,3          |
| 6                   | 0,1             | 0,6              | 0,3 » » 0,3          |
| 7                   | 0,15            | 0,9              | 0,4 » » 0,4          |
| 8                   | 0,15 "          | 0,9              | 0,4 » » 0,4          |
| 9                   | 0,2             | 1,2              | 0,5 » » 0,5          |
| 10                  | 0,2             | 1,2              | 0,5 » » 0,5          |
| 11                  | 0,2             | 1,2              | 0,6 >> » 0,6         |
| 12                  | 0,25            | 1,5              | 0,7 » » 0,7          |
| 13                  | 0,25            | 1,5              | 0,7 » » 0,7          |
| 14                  | 0,25            | 1,5              | 0,7 » » 0,7          |
| 15                  | 0,30            | 1,8              | 0,8 » » 0,8          |

При наличии у детей рвоты, вызванной токсикозом, синтомицин рекомендуется применять в виде свечей в двойной разовой дозе 4 раза в сутки ».

<sup>1</sup> Свечи готовятся по следующему рецепту: синтомицин по весу, масло какао 1,0, ланолин 0,05.

При прекращении рвоты синтомицин следует применять у этих больных внутрь по указанной выше схеме.

Лечение синтомицином должно продолжаться не менее 7 дней независимо от наступления улучшения как со стороны местных симптомов, так и общего состояния больного.

При проведении лечения синтомицином у больных с тяжелой и токсической формой дизентерии, а также диспепсии токсикоз исчезает обычно в первые дни от начала лечения.

Синтомицин в применяемых дозах не токсичен и хорошо переносится больными. Однако в отдельных случаях наблюдалось появление пятнисто-папулезной сыпи, которая держалась несколько часов и проходила без всякого вмешательства.

В токсических и гипертонических случаях дизентерии применение прогидрозентерийной сыворотки излишне, так как токсикоз снимается под влиянием лечения синтомицином.

При лечении синтомицином проводится обычная комплексная терапия (внутривенное введение 20% и 40% раствора глюкозы, сухой плазмы, витаминотерапия, переливание крови, диетотерапия и т. п.).

При гнойных осложнениях (отиты, пневмония и т. д.) лечение синтомицином не исключает необходимости одновременного применения пенициллина и других медикаментов.

В последнее время синтезирован новый антибиотик, близкий к синтомицину, — левомицетин, менее токсичный, чем синтомицин. Подробно о применении левомицетина см. гл. XVH *Фармакологические сведения, Левомицетин*.

Противодизентерийная сыворотка применяется только в тяжелых токсических случаях дизентерии, не позднее 3—4-го дня болезни. Сыворотка вводится внутримышечно, во всех случаях по методу Безредка; разовая доза 30 000—50 000 единиц (в зависимости от тяжести случая). При недостаточно эффективном действии сыворотки она вводится повторно. Сывороточное лечение дает лучший эффект у детей старше 3 лет. Одновременно с серотерапией проводится, и сульфидпнотерапия.

Благоприятные результаты в смысле уменьшения болей и смягчения тенезмов оказывает применение диатермии на область живота и применение общих теплых ванн.

Применение плазмы оказывает благоприятный эффект, уменьшая первичный токсикоз и способствуя повышению сопротивляемости против вторичных осложнений. Сухая плазма вводилась внутривенно по 50—100 г через день.

Переливание крови применяется в период вторичных осложнений; при затянувшихся формах и при развивающейся дистрофии производится повторно через 4—5 дней, обычно проводится 5—7 трансфузий из расчета 5—10 г крови на 1 кг веса.

Сердечно-сосудистые расстройства при тяжелых формах дизентерии требуют применения сердечных средств (кардиазол, кофеин, глюкоза) по общепринятым показаниям.

При наличии экзикоза и упорной рвоты<sup>1</sup> рекомендуется вливание физиологического раствора и раствора глюкозы-под кожу. При отсутствии рвоты желательнее жидкость вводить через рот.

Осложнения дизентерии (отфТ, мастоидит, пневмония, стоматит, молочница) лечатся по общим правилам.

При безбелковых отеках показана пища с достаточным содержанием полноценных белков (творог, мясо, рыба, яйца), необходимо также введение витаминов А, С и группы В в виде фруктовых соков, аскорбиновой кислоты, рыбьего жира, витамина В<sub>1</sub>, никотиновой кислоты.

При явлениях высыхания конъюнктивы склер рекомендуется промыть глаза физиологическим раствором и ввести каплями на конъюнктиву рыбий жир или стерильное вазелиновое масло.

Диета высококалорийная, полноценная, богатая витаминами и механически не раздражающая кишечник. В первые 2 дня болезни рисовый отвар, слизистые протертые супы, кефир, простокваша, ацидофильное молоко, овощные, фруктовые и ягодные с жи. В дальнейшем можно прибавить обезжиренный бульон, протертые каши, овощные и яблочное пюре, свежий протертый творог с сахаром, яйца всмятку, кисели, чай или кофе со сливками, белые сухари, черствый белый хлеб, мясное суфле, паровые котлеты, отваренную свежую рыбу.

**Профилактика.** Раннее выявление больных и их изоляция, текущая дезинфекция (заливка кала 10% раствором хлорной извести), борьба с мухами. Наблюдение за бактерионосителями; особое внимание обратить на работников пищевой промышленности, водоснабжения и детских учреждений. Учет больных хронической дизентерией, систематическая санитарно-просветительная работа среди населения.

Всем, находившимся в соприкосновении с дизентерийным больным, дается один раз в 10 дней по 10 мл бактериофага. Ежегодно в апреле — мае проводятся предохранительные прививки населения пентавакциной (одновременно и против брюшного тифа), а чаще противодизентерийными таблетками (по 1 таблетке 3 дня подряд натощак).

**ДИФТЕРИЯ (DIPHTHERIA).** Возбудитель — палочка диф<sup>те</sup>РШ-И. Инфекция передается от больного или дифтерийного бактерионосителя капельным путем или через загрязненные предметы.

**Симптомы и течение.** Инкубация — 3—7 дней. Различают дифтерию носа, зева, гортани и реже глаз и женских половых органов. На месте сосредоточения микробов образуется серовато-белый налет фибринозного характера в виде пленок; эти пленки часто выкашливаются (при поражении гортани и бронхов) в виде беловатых слепков с органов. Дифтерийная ангина развивается медленно. Вначале слабая боль при глотании. Налет появляется часто на первый день заболевания, с трудом снимается; при снятии его остаются капельки крови. Часто опухают шейные подчелюстные лимфатические узлы с отеком подкожной клетчатки. В тяжелых случаях налет часто имеет склонность распространяться на язычок и мягкое небо. Температура повышенная или субфебрильная и даже нормальная. Признаки дифтерийной интоксикации: расширенные зрачки, глухость тонов, аритмия, белок в моче; позже — дифтерийные полиневриты (парезы, параличи); паралич мягкого неба. При поражении слизистой носа отмечаются сукровичные выделения. При тяже-

•\*

лых поражениях гортани — затрудненное дыхание, у маленьких детей — в виде стенотического дыхания со втяжениями подложечной области и межреберных промежутков. Голос при этом делается хриплым, появляется лающий кашель (дифтерийный круп).

При дифтерии глаз — более или менее плотная опухоль век, обильное выделение гноя, на конъюнктиве век — трудно отделяемые серовато-желтые налеты.

При дифтерии входа во влагалище — припухлость, краснота, язвы, покрытые грязнозеленоватым налетом, и гнойное выделение.

**Распознавание.** Характерный дифтерийный налет; посев слизи из зева и носа и других мест поражения на свернутую лошадиную сыворотку и нахождение палочек дифтерии. Отрицательный результат посева не говорит против дифтерии при типичной клинической картине.

Наиболее часто встречающаяся дифтерия зева делится на распространенную форму (налет покрывает внутренние и передние поверхности небных миндалин, дужки и язычок), тонзиллярную форму (налет покрывает только миндалины), островчатую форму (в виде отдельных точек на миндалинах, дужках и язычке). Отдельно выделяется токсическая форма (бурное начало с температурой до 39—40°, распространение налетов по зеву, глотке, носоглотке, по слизистой носа с истечением кровянистой сукровицы и, главное, развитие большой отека вокруг увеличенных шейных желез).

Дифтерию зева следует отличать от простых ангин (при которых налеты легко удаляются и отсутствует отечность подкожной клетчатки вокруг увеличенных узлов), от скарлатинозной ангины (часто протекающей с омертвлением слизистой оболочки), от афтозного язвенного поражения слизистой рта и зева (при котором афты обнаруживаются часто на языке, губах), от молочницы (при которой имеются сплошные налеты не только в зеве, но и на слизистой щек, губ, языке) и, наконец, от язвенно-перепончатой ангины Венсана (при которой вначале тонкий, мягкий, серовато-зеленый налет на одной миндалине оставляет после себя кратерообразное углубление с грязным сероватым дном, ближайшие (регионарные) узлы при этом мало увеличены и самочувствие сравнительно удовлетворительное. Лечение. Специфическое лечение противодифтерийной сывороткой, которая вводится по методу Безредка внутримышечно, в легких случаях в дозах 5 000—10 000 АЕ (антитоксических единиц), в тяжелых случаях — 25 000—50 000 АЕ, при некрозах, кроме вливания\* противодифтерийной сыворотки, дают стрептоцид и пенициллин. При крупе, кроме сыворотки, требуется срочная интубация или трахеотомия во избежание смерти от удушья. При слабости сердечной деятельности — впрыскивание под кожу по 1—2 мл стрихнина (в растворе 0,1%). Строгий постельный режим и полноценное питание.

**Профилактика.** Изоляция больного на срок не менее 2 недель до исчезновения клинических явлений. Выписка больных производится лишь после двукратного исследования слизи на наличие палочек дифтерии с промежутком в 2—3 дня. Дезинфекция помещения и вещей больного. Обследование находившихся в соприкосновении с больным на дифтерийное бактерионосительство. Актив-

пая иммунизация детей дифтерийным анатоксином — двукратно 1 и 1,5 мл с промежутком в 2 недели, через 3—6 месяцев при положительной реакции Шика (внутрикожно 0,1 дифтерийного токсина) дополнительная-вакцинация в дозе 1,5 мл анатоксина. Бациллоносители не допускаются в детские учреждения.

**ИНФЕКЦИОННАЯ ЖЕЛТУХА (LEPTOSPIROSIS ICTERONAEOMORRHAGICA). БОЛЕЗНЬ ВАСИЛЬЕВА-ВЕЙЛЯ.** Возбудитель — лептоспир (особый вид спирохеты с большим количеством мелких завитков) Источник инфекции — грызуны, заражающие своей мочой пищевые продукты и воду, через которые и передается зараза. Входными воротами могут быть кожа и слизистые оболочки.

**Симптомы и течение.** Инкубация в среднем 7 дней. Внезапное начало с ознобом, высокой температурой, сильной головной болью и болью в икроножных мышцах. С 4—5-го дня лихорадки развивается желтуха, появляется альбуминурия, гематурия и склонность к другим кровотечениям (кровавая рвота, кровавый стул, кровавая мокрота). К 8—9-му дню температура падает, но нередко через 8 дней начинается второй приступ с теми же явлениями. Селезенка и печень увеличены, часто кожные кровоизлияния, нередко — носовые кровотечения. В крови нейтрофильный лейкоцитоз.

**Распознавание.** Лептоспиры можно выделить с 4-го дня болезни из крови, а с 8—10-го дня — из мочи путем посева или прививки морской свинке. С 8-го дня болезни получается положительная реакция агглютинации и лизиса лептоспир сывороткой кролика.

**Лечение.** Строгий постельный режим. Специфическое: введение внутримышечно сыворотки выздоравливающих (60—100 мл за сутки) или иммунизированных лошадей (до 100 мл на дозу). Уротропин 20—40% (1—2 мл внутривенно), пенициллин. При кровотечениях — хлористый кальций внутрь или внутривенно (10% по 10 мл). Углеводно-фруктовая диета.

**Профилактика.** Очистка и охрана водных\* источников. Охрана пищевых продуктов от крыс. Уничтожение грызунов

**КАЛА-АЗАР** см. *Лейгманиоз*.

**КОКЛЮШ (PERTUSSIS).** Возбудитель — палочка Борде-Жангу. Болезнь передается непосредственно от больного человека к здоровому капельным путем.

**Симптомы и течение.** Характерен второй период болезни (7—10-й день), при котором развивается судорожный кашель приступами (от 10 до 50 приступов в течение дня), заканчивающийся рвотой. Лицо во время приступа одуловатое, цианотичное. Кашель сопровождается свистящим звуком. Часты надрывы подъязычной уздечки.

Инкубация от 2—10 дней до 3 недель. В первый (катаральный) период болезни — неопределенная, часто субфебрильная температура с насморком, конъюнктивитом, обычным кашлем. Через неделю наступает второй (судорожный) период с приступами судорожного кашля. В третьем периоде (разрешение болезни) наблюдаются единичные легкие приступы. Осложнения при коклюше: бронхит,

пневмония, эмфизема легких. Продолжительность коклюша около 4—5 недель; в тяжелых случаях — до 12 недель.

**Распознавание** Для ранней диагностики и в стертых случаях болезни (без выраженного судорожного кашля) применяется бактериологический метод при помощи кашлевых пластинок (чашки Петри со средой Борде-Жангу держат на расстоянии 10 см от рта кашляющего больного). Применяется еще серологическая реакция связывания комплемента с убитой культурой палочки Борде-Жангу. Коклюш следует отличать от гриппа, кори, коклюше-подобного кашля у детей (с склонностью к судорогам при аденоидных разрастаниях). \*Коклюшный кашель отличается приступами большей частью в определенные часы ночи и постепенно становится судорожным.

**Лечение.** Специфическое лечение вакциной (в несколько приемов 7—8 мл вакцины с содержанием около 10 млрд. микробных тел в 1 мл). Свежий воздух. Освещение кварцем. Полноценное питание.

**Профилактика.** Разобщение (изоляция) больных на 40 дней от начала болезни. Выявление больных со стертыми формами коклюша в окружении больного и их разобщение. Разобщение (на 21 день) соприкасавшихся, не болевших коклюшем. Проводится экспериментальная активная иммунизация вакциной. Соприкасавшимся детям можно производить пассивную иммунизацию сывороткой выздоравливающих, взятой на 4-й неделе болезни, в дозу 3—8 мл.

**КОРЬ (MORBILLI).** Инкубация в среднем 10—12 дней, у непритянутых до 28 дней. Возбудитель — фильтрующий вирус. Болезнь передается от больного человека к здоровому капельным путем. Важно знать, что вирус кори легко проникает в соседние комнаты или палаты больничного отделения. Восприимчивость неболевших почти поголовная. Больной считается заразным в последний день инкубации и особенно во время катаральных явлений до момента высыпания.

**Симптомы и течение.** Болезнь начинается предвест-, \* пиковыми явлениями в виде чихания, насморка, кашля, конъюнктивита, светобоязни. За 1—2 дня до высыпания на слизистой щек (на гиперемической слизистой оболочке в области коренных зубов) появляются белые пятна Филатова-Коплика. На 4-й день болезни появляется коревая сыпь, в виде розовых, немного возвышающихся над поверхностью, местами сливающихся, пятен величиной с чечерипу\*Высыпание начинается за ушами, на лице и быстро распространяется на туловище, верхние и нижние конечности. В такой же последовательности сыпь постепенно исчезает, оставляя после себя пигментацию. Через неделю после высыпания на теле появляется мелкое отрубевидное шелушение. Осложнения: чаще коревая пневмония с склонностью к бронхоэктазии, далее — ложный круп, который можно принять за дифтерийный; гнойное воспаление среднего уха и энтероколит. У привитых корь (митигированная корь) протекает при нерезких катаральных явлениях с невысокой температурой (до 38°) и болезнь заканчивается через несколько дней. Перенесенная корь оставляет после себя прочную невосприимчивость.

**Р а с п о з н а в а н и е .** На основании анамнеза (соприкосновение с больными), наличия катарральных явлений, пятен Филатова-Коплика и коревой сыпи (начало высыпания и локализации сыпи).

Следует исключить: грипп (отсутствие пятен Филатова Коплика); скарлатину (яркокрасный зев, характер сыпи и ее распространение сверху вниз, с кожи позади ушных раковин); краснуху (увеличение затылочных узлов). При узелковой форме кори исключаются: натуральная оспа (при которой узелки более плотны, лежат глубже в коже и появляются после падения температуры); сыпной тиф (менее интенсивная окраска сыпи, не распространяющаяся сверху вниз с лица); сывороточную и лекарственную сыпь (отличается по анамнезу и сопутствующим признакам).

**Л е ч е н и е .** Специфического лечения нет. При осложнениях кори пневмококковой или стрептококковой пневмонией, кроме сульфаниламидных препаратов, хорошее действие оказывают инъекции пенициллина. Лечение неосложненной кори сводится к хорошему уходу.

**П р о ф и л а к т и к а .** Разобщение больных до 7-го дня после падения температуры. Серопротекция всем соприкасавшимся с больным и не болевшим ранее корью, в первую очередь детям до 7 лет (по 30—60 мл сыворотки взрослых людей или плацентарной сыворотки внутримышечно). Среди окружающих изолируют не болевших, посещающих детские коллективы, на 21 день без применения серопротекции и на 28 дней с применением серопротекции. Прекрасный эффект дает профилактическое введение гамма-глобулина (доза 1,5—2 мл).

**К Р А С Н У Х А (RUBEOLA).** Возбудитель неизвестен. Передается капельным путем. Различают краснуху коревую и скарлатинозную.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Длительность инкубационного периода 14—23 дня для коревой краснухи и 9—21 день для скарлатинозной В периоде предвестников — чихание, кашель, конъюнктивит.

В начале болезни появляется сыпь, напоминающая коревую или скарлатинозную. Характерный признак — безболезненные увеличенные затылочные и задние шейные узлы. Отсутствуют пятна Филатова-Коплика при коревой краснухе и ангина при скарлатинозной краснухе. Температура от субфебрильной до 39° держится 2—3 дня. Сыпь не оставляет пигментации и не дает шелушения.

8 нсее — бледная сыпь. Особых осложнений не дает. Коревая и скарлатинозная краснуха не дают взаимного иммунитета и являются совершенно самостоятельными.

**Р а с п о з н а в а н и е .** На основании клинических признаков (увеличение затылочных желез), легкости течения.

**Л е ч е н и е .** Лечение обычно не требуется.

**П р о ф и л а к т и к а .** Разобщение больных на 10 дней от начала заболевания. Соприкасавшиеся не допускаются в детские учреждения в течение 14 дней.

**Л Е Й Ш М А Н И О З (LEISCHMAMOSIS).** Возбудитель — лейшманий, относящиеся к простейшим паразитам. Болезнь встречается главным образом в теплых странах (у нас в Средней Азии, Закавказье). Передатчик — москит *Phlebotomus*. Главный источник за-

разы — грызуны (песчанки, хомяки), собаки. Возможна передача болезни от больных людей здоровым. Лейшманиоз встречается в виде двух клинических Лорм: внутренний лейшманиоз (кала-азар) и кожная форма — пендинская язва (годовик), чаще встречающаяся в сельских местностях в Средней Азии

**Внутренний лейшманиоз (тла-азар).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е . Инкубация от 10—20 дней до нескольких месяцев. Болезнь начинается исподволь, нарастающей слабостью, расстройством кишечника (поносы). Селезенка постепенно увеличивается и к разгару болезни достигает огромных размеров (опускается в малый таз) и большой плотности Увеличивается также и печень. Температура дает большие колебания. На коже появляются различного вида сыпи, большей частью узелкового характера' кожа сухая, бледно-землистого цвета Наклонность к кровотечениям. Постепенно развивается худосочие (кахексия) и-малокровие (до 15—18% гемоглобина и до 2 млн. эритроцитов). В крови — лейкопения с большим лимфо-питозом и моноцитозом. Большие отеки. Смертность — довольно большая среди долеченных.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Типичные признаки: резко увеличенная селезенка (спленомегалия), увеличенные печень и лимфатические з'злы, перемежающаяся температура с двумя или тремя подъемами в течение суток Точный диагноз может быть .(оставлен лишь проколом селезенки или рукоятки грудины (костный мозг) и нахождением возбудителя (лейшманий) Заболевание может быть ошибочно принято за малярию, при которой температура чаще интер миттирующего характера, селезенка не спускается в малый таз и не такой плотной консистенции При пункции селезенки надо остерегаться рчзрыва, для этого больного кладут на правый бок и хорошо фиксируют руками селезенку.

Малярия подтверждается нахождением плазмодиев в толстой капле крови.

**Л е ч е н и е .** Специфическое: внутривенные вливания препарата сурьмы: 1% раствор рвотного камня (Stibiokaliun lar-taricum) по 1—5 мл детям и 5—10 мл взрослым через день до исчезновения клинических признаков и лейшманий в костном мозгу или селезенке. Весьма эффективным считают подкожное введение нестибозана и солосурьмина в виде 5% растворов.

Rp. Sol. Stibio kalii tartarici 1% 30,0

Stenilisetur!

DS. Для подкожного введения детям 2—5 мл, взрослым 5—10 мл ежедневно 1—2 месяца

**Кожная форма лейшманиоза (пендинская язва).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е . Инкубационный период от 1 недели до 2—3 месяцев. Пендинская язва длится около 1 года. Отмечается три периода: узелковый, язвенный и период рубцевания. Цвет узелка обычно синевато-красный, величина — от чечевицы до фасоли. Через 3—4 месяца в центре узелка появляется некроз и начинается изъязвление. Нередко из язвы выделяется обильное серозно-гнойное отделяемое, засыхающее в желто-коричневую корку.

При рубцевании в окружности язвы образуются венчики различной величины, напоминающие волчанку. Кожный лейшманиоз часто поражает открытые части тела (лицо, верхние и нижние конечности).

Для кожного лейшманиоза характерно при развившейся язве наличие плотного краевого вала над уровнем язвы и здоровой кожи.

Возбудитель кожного лейшманиоза открыт русским ученым П. Ф. Боровским в 1898 г.

**Распознавание.** Анамнез (укусы москитами) в типичное клиническое течение. Микроскопическое исследование соскоба из язвы па лейшмании.

**Лечение.** Кожная форма лейшманиоза хуже поддается специфическому лечению препаратами сурьмы. Применяются мази из препаратов сурьмы, а также рентгено- и радийтерапия.

При лечении кожного лейшманиоза хорошие результаты дает пропитывание еще не изъязвленных узелков 3—5% раствором акрихина.

**Профилактика.** Борьба с москитами, уничтожение грызунов, больных лейшманиозом собак.

**ЛИХОРАДКА ПАППАТАЧИ** см. *Москитная лихорадка*.  
**МАЛЯРИЯ (MALARIA). БОЛОТНАЯ ЛИХОРАДКА.** Возбудитель — малярийные паразиты (плазмодии) различных видов (для трехдневной малярии — *Plasmodium vivax*, для четырехдневной — *Plasmodium malariae*, тропической — *Plasmodium falciparum*; реже встречается четвертый вид — *Plasmodium ovale*). Источник инфекции — больной человек и гаметоноситель; передатчик от них здоровому человеку — комар рода *Anopheles*. Возбудитель малярии — малярийный плазмодий — имеет сложный цикл размножения, распадающийся на половой, протекающий в комарах рода *Anopheles* (спорогония), и бесполой, протекающий в человеке (шизогония).

Резервуар вируса, от которого заражаются комары, — больной человек. Свежие заболевания малярией возможны при наличии двух факторов: человек — носитель гаметоцитов и комар-передатчик. Домашние животные (лошади, коровы) отвлекают комаров на себя и тем самым уменьшают возможность заражения человека.

**Симптомы и течение.** Длительность инкубационного периода 9—11 дней. При осеннем заражении заболевание может появиться зимой. Признаки малярии типичны: приступы, начинающиеся часто потрясающим ознобом с последующим резким повышением температуры, критическим ее падением и обильным потоотделением; увеличенная плотная селезенка, увеличенная печень. Приступы чередуются: при трехдневной малярии — через каждые 48 часов, при четырехдневной — через 72 часа, при тропической — неправильно чередующиеся приступы каждые 24—48 часов, часто непосредственно следующие один за другим. Приступы могут наблюдаться ежедневно при двойном или тройном заражении. Приступы длятся 8—12 часов. Во время приступа больные жалуются на головную боль, боль в мышцах, суставах и в области селезенки. Кожа часто серовато-желтушной окраски на лице герпес. Кровь: нарастающее малокровие, лейкопения с лимфоцитозом. При малярии происходит глубокое поражение всего организма, отражаю-

щееся па функции всех органов, из которых особенно ранимым является головной мозг (коматозные формы).

Длительность малярии: для трехдневной формы 18—20 месяцев, для тропической — не больше года, для четырехдневной — до 3 лет и больше.

**Осложнения:** малярийная кома (тяжелая общая интоксикация, нарушенное сознание, нередко мешшгальные явления); малокровие, иногда даже злокачественного характера, поражение печени и почек; серьезное значение имеет гемоглобинурийная лихорадка (вследствие бурного распада эритроцитов).

**Распознавание.** По характерным клиническим признакам и нахождению паразитов (плазмодиев) в мазках крови и особенно в толстой капле, взятой на высоте приступа во время лихорадки. Ранняя диагностика, имеющая важное значение для лечения и профилактики малярии, возможна при взятии толстой капли крови у каждого человека для исследования на плазмодии малярии. При атипичной температуре необходима дробная термометрия.

Малярию необходимо отличать от сепсиса, туберкулеза, сыпного, брюшного и возвратного тифа, в южной полосе СССР — от лейшманиоза и москитной лихорадки (болезнь паппатачи) путем определения септического очага, тщательного обследования легкие уст: нетления точного эпидемиологического тифозного анамнеза и клинического разбора, характерного увеличения селезенки (при лейшманиозе) и симптомов Пика и Тауссига (при москитной лихорадке).

**Лечение.** Раннее, упорное, систематическое (курсовое).

Курсовое лечение акрихином: первые два дня по 0,4 на прием два раза в день (ударные дозы) и 3 дня по 0,1 три раза в день; чер! 10 дней опять 3 дня по 0,1 три раза в день, через 10 дней также. При приемах акрихина возможна желтушная окраска кожи.

Лечение хинином: внутрь по 1,0—1,5 в день (по 0,5 два-три раза в день или по 0,25 четыре-пять раз в день) по схеме: 5 дней прием, 4 дня перерыв, 3 дня прием, 4 дня перерыв: такое лечение проводят 4—5 раз подряд, независимо от наличия приступов. Плазмодии назначают при рецидивах по 0,02 три раза в день (не превышать дозы!) в сочетании с акрихином или хинином. Плазмодии действуют на половые формы (гаметы) плазмодия.

Против малярийной комы применяют акрихин или хинин. Акрихин — по 0,1 внутривенно (5 мл 2% раствора), через 4—6 часов 0,2 внутримышечно и через 8—12 часов еще раз 0,1 внутривенно; хинин — по 0,5 (50 мл 1% раствора солянокислого хинина) внутривенно и дополнительно внутрь не меньше 1,0. После устранения комы переходят на обычные методы лечения малярии (акрихином или хинином). Недавно в практику введен новый советский синтетический препарат бигумаль, быстро разрушающий шизонты трехдневной и тропической малярии. Лучше применять растворимый уксуснокислый бигумаль (до 2% при 20°), применяется главным образом парентерально. Схема лечения тропической малярии — один пятидневный цикл: первый день 0,3x2; 2—5-й день — 0,15x2; при трехдневной малярии по окончании этого цикла бигумаль назначают по 0,1 один раз в неделю в течение 3—6 месяцев

**Профилактика.** Строгий учет всех малярийных больных и систематическое их лечение. Лечение рецидивов проводится в апреле акрихином или хинином в дозах, равных  $\frac{1}{3}$  обычных доз. Борьба с комарами: заливка водоемов нефтью, разведение в них рыбки гамбузии, осушка болот и др. Химиофилактика проводится во все время пребывания в малярийной местности и в течение 2 недель по выезде оттуда по 0,5—1,0 хинина каждый 5-й день или по 0,2 акрихина через каждые два дня на третий. Защита людей от укусов комара в ночное время достигается засетчиванием жилых помещений.

**МЕНИНГИТ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНЫЙ (ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ОБОЛОЧЕК СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА).** Возбудитель — менингококк Вексель-баума. Передается инфекция от больного или бактерионосителя капельным путем. Заражение происходит преимущественно от здоровых бактерионосителей, которые легко обнаруживаются в окружении больного. Менингококк оседает главным образом в мягких мозговых оболочках, вызывая в них гнойное воспаление. В центральную нервную систему он проникает через носоглотку. Его можно всегда обнаружить в крови путем посева.

**Симптомы и течение.** Инкубация 2—7 дней. Болезнь начинается внезапно, высокой температурой, сильной головной болью и рвотой. Вскоре развиваются менингеальные признаки: тугоподвижность затылка, запрокинутая назад голова, симптом Кернига (невозможность разогнуть в колене ногу, согнутую в тазобедренном суставе, или согнуть в тазобедренном суставе ногу, разогнутую в колене), симптом Брудзинского (при пригибании головы к груди сгибаются ноги в коленных суставах). Отмечается еще повышенная чувствительность, гиперестезия). Нередко присоединяются параличи (гемиплегии, моноплегии) и различные судороги. Нейтрофильный лейкоцитоз (30 000—40 000 лейкоцитов). 1 (улье, дыхание учащены. При менингококковом сепсисе на коже нетехии (точечные кровоизлияния), часто герпес.

Осложнения: головная водянка, глухота вследствие поражения слухового нерва и внутреннего уха; слепота вследствие поражения зрительного нерва или сосудистой оболочки глаза.

**Распознавание.** На основании клинической картины и данных исследования спинномозговой жидкости. При поясничном проколе (между III—IV поясничным позвонком) получается под большим давлением мутная жидкость, содержащая большое количество нейтрофильных лейкоцитов и менингококков, при туберкулезном менингите жидкость прозрачная, образующая при стоянии нежную паутиннообразную сеточку и содержащая в осадке преимущественно лимфоциты и туберкулезные палочки.

Эпидемический цереброспинальный менингит дифференцируется: от туберкулезного менингита (более быстрым развитием, наличием г-рпеса на лице и других частях тела, главным образом характером спинномозговой жидкости — мутная при эпидемическом и прозрачная при туберкулезном менингите); от острых вторичных менингитов (брюшной тиф, сыпной тиф, пневмония, воспаление среднего уха) — наличием основных признаков заболевания.

**Лечение.** Мощное терапевтическое средство — сульфидин в дозе 1,0 через 4 часа в течение 5—6 дней для взрослого, по 0,2 на 1 кг веса для детей (на курс лечения). Противоменингококковая сыворотка по 10—15 мл в спинномозговой канал и 50 мл внутримышечно (в течение 5—6 дней). В тяжелых случаях лучше комбинированное лечение (сульфидином и сывороткой). Ежедневные или через день спинномозговые проколы. С успехом применяется также пенициллин (по 50 000—100 000 единиц через 3 часа в течение 6—8 дней).

**Профилактика.** Изоляция больных. Выписка больных производится после двукратного отрицательного посева слизи носоглотки на менингококк. Обследование окружающих на бактерионосительство.

**МОСКИТНАЯ ЛИХОРАДКА. ЛИХОРАДКА ПАППАТАЧИ (MORBUS PAPPATASII).** Возбудитель — фильтрующий вирус. Источник инфекции — дикие грызуны и, повидимому, больной человек. В крови человека вирус обнаруживается за 1—2 дня до подъема температуры и в первые 24—36 часов заболевания. Передатчик болезни — комар Phlebotomus. Болезнь встречается в теплых странах, у нас в Средней Азии, Закавказье, Крыму.

**Симптомы и течение.** Инкубация 3—5 дней. Начало — внезапное повышение температуры до 40°, появление сильной головной боли, боли в глазах, особенно при движении ими в стороны, боли в мышцах всего тела. Сильная гиперемия лица, конъюнктивит, симптом Пика — расширение сосудов в виде треугольника у наружного угла глазного яблока. Симптом Тауссига — боль при надавливании на глазное яблоко. Резкая слабость. Температура падает через 3—4 дня без пототделения. Пульс отстает от температуры, иногда даже брадикардия. В крови — лейкопения с лимфо-цитозом, моноцитоз.

**Распознавание.** Диагноз ставится в эпидемических очагах на основании характерных симптомов (симптом Пика и Тауссига).

**Лечение.** Особого лечения не требуется. При болях — аспирин, пирамидон.

**Профилактика.** Изоляция больных. Предохранение от укусов комаров. Уничтожение очагов выплода комаров; очистка территории, жилья (флицидом, пиретрой) и других построек от всякого мусора и отбросов.

**ОСПА ВЕТРЯНАЯ (VARICELLA).** Возбудитель — фильтрующий вирус, который фиксируется клетками слизистой верхних дыхательных путей и здесь размножается: разносится кровяным током. Источник заражения — больной человек. Заражение происходит капельным путем.

**Симптомы и течение.** Инкубация 14—21 день. Болезнь начинается после короткого продромального периода быстрым подъемом температуры, сопровождающимся появлением характерной многообразной сыпи (пятна, узелки, пузырьки, корочки). Сыпь локализуется преимущественно на волосистой части головы, на груди и спине. На слизистой дыхательных путей (глотки, гортани и трахеи) развивается энантема (пятнистая сыпь). Каждое новое высыпание сопровождается подъемом температуры. Пузырьки одно-



камерные без вдавления в центре. По отпадении корочек рубцов не бывает. Общее состояние больного мало нарушено; иногда отмечается сильный зуд в местах сыпи. В тяжелых случаях сыпь, обычно везикулезная (пузырьковая), становится пузырьчатой (гноиничковой), геморрагической (кровооточивой) или гангренозной, что вызывает затруднения в распознавании болезни.

**Р а с п о з н а в а н и е .** На основании анамнеза (соприкосновение с больными), характера сыпи и течения болезни можно подтвердить диагноз нахождением в содержимом пузырьков элементарных телец Араго.

Ветряная оспа отличается от натуральной оспы повышением температуры в момент высыпания, многообразием сыпи на ограниченном участке кожи, отсутствием пупкового вдавления в пузырьках, от вариолоида (легкой формы оспы) — реакцией Пауля с <ю-держимым везикул (втирание в роговицу глаза кролика).

**Л е ч е н и е .** Специфического лечения нет. Сыпь смазывают 1% зеленой (бриллиант-грюн), зуд успокаивается при обмывании перекисью марганца.

**П р о ф и л а к т и к а .** Изоляция больных до отпадения корочек. Разобщение на 23 дня детей, находившихся в соприкосновении с больным, причем для детей до 4 лет применяется пассивная иммунизация сывороткой взрослых (как против кори).

**ОСПА НАТУРАЛЬНАЯ (VARIOLA VERA).** Возбудитель — фильтрующийся вирус, обнаруживаемый в содержимом оспин в виде телец Пашена. Передается капельным путем от больного здоровому, а также через предметы, бывшие в соприкосновении с больным.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Инкубация 12—14 дней. Болезнь начинается бурно, высокой температурой, болями в голове и пояснице, иногда бывает бред и рвота. Температура держится 3 дня. На 4-й день появляется розовая узелковая сыпь сначала на лице, волосистой части головы, потом на туловище, верхних, а затем и нижних конечностях, через 3 дня узелки превращаются в пузырьки с прозрачным содержимым. В течение последующих 3 дней пузырьки превращаются в гноинички с вдавлением в середине в виде, пупка. Температура вновь поднимается, имея перемежающийся характер; через 6—7 дней она снижается, гноинички подсыхают и образуются корки, постепенно затем отпадающие. Этот период длится около 3 недель. Продолжительность оспы — около 6 недель. По отпадении корок образуются рубцы (рябины). На слизистой зева, неба и на конъюнктивах очень рано образуются пузырьки, затем они лопаются и образуются язвочки. Поражение роговицы приводит часто к слепоте. Через вскрывшиеся пузырьки может проникнуть вторичная инфекция, стафилококковая или стрептококковая с образованием флегмон, гноиников, рожевого воспаления и даже повести к сепсису.

Серьезное осложнение — пневмония. Если гноиничные пузырьки сливаются, получается сливная оспа. Течение принимает более грозный характер, когда в пузырьки просачивается кровь и сыпь принимает темносине-багровый цвет (геморрагическая, черная оспа). Абсолютно смертельной является оспенная пурпура, при которой уже в начальном периоде появляются на коже крупные кровоизлия-

»

ния, кровотечения носовые, из слизистых оболочек, кровавая рвота, гематурия, маточные кровотечения.

У привитых встречается легкая, стертая форма оспы — варио-лоид с незначительной, иногда единичной сыпью, заканчивающейся без нагноительного периода.

**Р а с п о з н а в а н и е .** На основании характерной клинической картины (высыпание после падения температуры) и закономерности в развитии сыпи. В сомнительных случаях необходимо исследовать содержимое пузырька на наличие телец Пашена и на феномен Пауля (втирание содержимого узелка в роговицу глаза кролика с последующей обработкой места укола 1% спиртовым раствором сулемы)? Имеет важное значение п анамнез (контакт).

Натуральная оспа, особенно вариолоид, отличается от ветряной плотностью основания пузырька, спадением температуры к моменту высыпания, характерной локализацией на не покрытых одеждой местах, на ладонях и ступнях; от кори — отсутствием катар-ральных явлений и пятен Филатова-Коилика и также спадением температуры к моменту высыпания; от скарлатины — отсутствием ангины и увеличения шейных желез.

**Л е ч е н и е .** Симптоматическое. Тщательный уход за кожей п глазами. Для предохранения роговицы впускают в глаза раствор метиленовой синьки (1 : 1 000). Для облегчения зуда и поддержания чистоты кожи — теплые ванны с прибавлением шчѣкисы марганца. Для предупреждения образования глубоких рубцов (рябин)— ртутный пластырь на лицо. При осложнениях рожей — стрептоцид по 0,5 4—6 раз в день, при пневмонии — сульфидин. Сердечные средства — камфора, кофеин.

**П р о ф и л а к т и к а .** Систематическое проведение вакцинаций и ревакцинации в законодательном порядке. Первая прививка (вакцинация) делается на первом году жизни, повторные прививки (ревакцинация) — в возрасте 4—5, 10—11 и 18—20 лет. Прививка проводится следующим образом. Кожу на плече тщательно дезин-фицируют спиртом или эфиром. Затем оспопрививательной иглой, смоченной в оспенном детрите, делают 2—3 поверхностных надреза кожи на расстоянии 2 см друг от друга (но до крови!). На 4-й день на месте прививки образуется узелок, к 7-му дню появляется пузырек и гноиничок, начинающий к 12—14-му дню подсыхать, образуя корку, которая отпадает через 15 дней. Прививка в очаге производится всем лицам, бывшим в соприкосновении с больным и во всем населенном пункте. Разобщение (изоляция) на 14 дней. Тщательная дезинфекция Помещения и транспорта, доставившего больного.

**ПАРАТИФЫ А и Б (PARATYPHUS А и В).** Очень сходные по клинике п эпидемиологии с брюшным тифом болезни. Возбудитель — палочка паратифа А (при паратифе А.) и паратифа Б (при паратифе Б). Источник инфекции — больной человек или выздоровевший носитель паратифозной палочки. Болезнь встречается чаще в теплых странах.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** При паратифе А нередко более раннее п более обильное высыпание розеол, чем при брюшном тифе. В остальном течение болезни весьма сходно с брюшным тифом (см.). При паратифе Б более короткая инкубация. Иногда — герпес на

губах, познабливание. Сыпь возвышенная розеолезная, обильная, может появиться на 5—6-й день болезни в отличие от брюшного тифа. Иногда умеренный лейкоцитоз. Нередко паратиф B дает признаки острого желудочно-кишечного катарра (рвота и понос).

В отличие от брюшного тифа более легкое течение с коротким лихорадочным периодом, в среднем 2—3 недели. Осложнения могут быть такие же, как и при брюшном тифе (кишечное кровотечение, прободение и т. д.).

**Распознавание.** Производится исключительно бактериологически посевом крови и серологически — реакцией агглютинации Видаля.

**Лечение.** Как и при брюшном тифе (см.).

**Профилактика.** Общесанитарные мероприятия и специфические прививки, как при брюшном тифе.

**ПАРОТИТ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ** см. *Эпидемическое воспаление околоушной железы.*

**ПЕНДИНСКАЯ ЯЗВА** см. *Лейшманиоз.*

**ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ. ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ.** Возбудитель — микробы из группы сальмонелл (палочки Breslau, supestifer и Gartneri). Источник болезни — мясо домашних животных, зараженное при жизни или после убоя их (при хранении или обработке), мясные продукты (колбасы, консервы, печенка, студень, фарши, супы, мясные и рыбные продукты). Возбудитель может быть найден в первые дни в кале заболевших и в мясных продуктах, вызвавших заболевание у людей. Заболевание развивается вследствие отравления токсинами микробов.

**Симптомы и течение.** После короткой инкубации (от нескольких часов до 2—3 дней) начинается расстройство пищеварения, часто в виде тошноты, многократной рвоты, поносов и болей в животе. Температура может быть повышенной или субфебрильная. В тяжелых случаях наблюдаются судороги, цианоз (синюха), похолодание конечностей, понос с рвотой (холерина). При тяжелой токсемии (отравление крови) — падение сердечно-сосудистой деятельности (коллапс).

**Распознавание.** Большое значение имеет анамнез (употребление в пищу недоброкачественных мясных продуктов и наличие сходных заболеваний у лиц, употреблявших ту же пищу). Для уточнения диагноза — посев кала и рвотных масс.

**Лечение.** В легких случаях слабительные и тепло на живот (грелки); в тяжелых случаях — в первые часы заболевания — промывание желудка, тепло на живот, внутривенное введение атропина 0,5—1,0 (в растворе 1 : 1 000); подкожные и внутривенные вливания 300—500 мл физиологического раствора; внутривенно 30—50 мл глюкозы. При сердечной слабости — внутривенное введение камфоры и кофеина. Большое значение имеет диета: вначале голодание, затем постепенный переход к обычной пище.

**Профилактика.** Немедленное изъятие из употребления подозрительных пищевых продуктов и бактериологическое исследование их. Строгий санитарный надзор за убоем скота и состоянием боен, пищевого блока (места приготовления пищи), за условиями перевозки, обработки и хранения мяса, консервов.

**РОЖА (ERYSIPELAS).** Возбудитель — рожистый стрептококк. Заражение происходит чаще при нарушении целостности кожи загрязненными предметами, инструментами или руками. Лица, уже разболевшиеся рожей, имеют повышенную чувствительность к роже.

**Симптомы и течение.** Инкубация 3—5 дней. Болезнь начинается остро, с повышенной температурой и появлением характерной припухлости (возвышенный валик, резко отграниченный от здоровой кожи), покраснения и болезненности пораженного участка кожи.

Различают эритематозную форму рожи в виде покраснения и отека кожи, буллезную форму с пузырями на воспаленной коже, наполненными серозным выпотом, и флегмонозную форму, когда воспаление с кожи проникает в подкожную клетчатку. По месту локализации различают местную (носа, лица, головы, спины и т. д.) и блуждающую рожу, переходящую из одного места на другое. Рожистым воспалением могут поражаться и слизистые оболочки.

**Распознавание.** Рожа отличается: 1) от флегмоны, при которой опухоль плотная с постепенным угасанием воспалительной красноты и болезненности от центра к периферии; 2) от сибирской язвы, при которой наблюдается резкий отек подкожной клетчатки.

**Лечение.** Внутрь стрептоцид 3—5 г в день и одновременно эритемные дозы кварцевой лампы в течение 3 дней по 5—10 минут в день; противовирусные примочки или мази по Безредке. При отсутствии положительного результата от стрептоцида — лечение пенициллином.

**Профилактика.** Гигиеническое содержание кожи, особенно лицами, уже болевшими рожей. Тщательное соблюдение асептики при операциях, родах и инъекциях. В больничных случаях изоляция заболевших, в особенности в родильных и хирургических отделениях.

**САП (MALLEUS).** Возбудитель — палочка сапа. Сап встречается в виде эпизоотии (повальной болезни) среди лошадей, от которых инфекция передается капельным путем через слизистые оболочки и поврежденную кожу людям, непосредственно соприкасающимся с лошадьми (ветеринарные работники, конюхи и т. д.).

**Симптомы и течение.** Инкубация 3—5 дней. Внезапное начало: повышение температуры, озноб, боли в мышцах и суставах и появление инфильтрата в области входных ворот инфекции с рожистоподобной краснотой вокруг. Через несколько дней на коже и слизистых оболочках появляются вторичные узелки. Эти узелки переходят в абсцессы и язвы с характерным салным дном, подрытыми краями и развиваются; регионарные лимфангоиты (воспаление лимфатических сосудов) или лимфадениты (воспаление лимфатических узлов). На слизистой носа образуются изъязвления, выделяется сукровичная жидкость. В мышах часто появляются некротические очаги.

Часто осложняется пневмонией с выделением кровавой мокроты и смертельным исходом.

Течение хронического сапа (процесс тянется несколько лет) менее бурное (чем при острой форме), часто в виде медленно развиваю-

ического сепсиса с обострениями и образованием абсцессов и характерных язв на слизистой оболочке верхних дыхательных путей; из образовавшихся свищей выделяется гной, содержащий сапные палочки; при локализации процесса в легких отмечается затяжная ползучая форма плевропневмонии. При хронической форме сапа нередко случаи выздоровления.

**Распознавание.** Важное значение имеет анамнез (профессия). Бактериологическое исследование: кровь, мокроту, содержимое прыщей и гнойников впрыскивают внутрибрюшинно самцу морской свинки, у которого через несколько дней развивается воспаление яичка (реакция Штрауса), откуда и выделяется культура сапной палочки. Для диагноза особенно скрытых форм сапа имеет значение проба с маллеином (фильтрат бульонной культуры сапной палочки). Человеку эта проба делается в виде кожной пробы по Пирке в дозе 0,1 мл разведенного в 10 раз маллеина. Лошадям вводят подкожно 1 мл маллеина и еще чаще 0,2 мл в конъюнктиву (при положительной реакции появляется сильное гноетечение из глаза).

**Лечение.** Ртутные втирания, облучение кварцевой лампой, прижигание язв. Гнойники вскрываются.

**Профилактика.** Ветеринарный надзор за лошадьми и выявление у них скрытых форм маллеиновой пробой. Осторожный уход за больными лошадьми в спецодежде и строгое проведение дезинфекции. Больные подлежат изоляции на весь период болезни. При уходе за легочными больными персонал надевает защитные маски и очки.

**СВИНКА. ЗАУШНИЦА** см. *Эпидемическое воспаление околоушной железы.*

**СИБИРСКАЯ ЯЗВА (ANTHRAX).** Возбудитель — спороносная сибирезвездная палочка, очень устойчивая по отношению к действию высокой температуры и дезинфицирующих веществ. Заражаются люди при непосредственном контакте с больными домашними животными (лошади, коровы, свиньи и др.) или вдыханием пыли от предметов, приготовленных из кожи и волос больных животных (одежда, щетина, шерсть, мех и т. д.). Возможно заражение при употреблении мяса (колбасы) больных сибирской язвой животных (кишечная форма). Некоторое значение при заражении имеют насекомые (слепень, мухажигалка). Различают три формы сибирской язвы: кожная (наиболее частая), легочная и кишечная. Легочная форма часто встречается у трупщиков и меховщиков.

**Симптомы и течение.** Инкубация от нескольких часов до 2—3 дней.

Кожная форма: сначала на месте внедрения возбудителя образуется красное зудящее пятнышко, потом папула (узелок); через несколько часов в центре узелка появляется кровянистый пузырек, который лопаются и образуется струп, в окружности его часто образуются вторичные кровянистые пузырьки, которые также лопаются и, сливаясь с центральным струпом, дают сплошной черный крупный струп. В окружности его развивается отек, особенно выраженный в местах с рыхлой подкожной клетчаткой, например, при поражении верхней губы отек может распространиться на всю шею до рукоятки грудины и слизистую верхних дыхательных путей

и вызвать явления асфиксии (удушения). Язва не болезненна. На 2-й день повышается температура, которая в легких случаях критически падает через 5—6 дней; общее состояние мало нарушено. В тяжелых случаях развивается сепсис с метастатическими высыпаниями на коже, с наклонностью к кровотечениям. В крови при этом много сибирезвездных палочек.

При легочной форме развивается картина бурной бронхопневмонии, которая часто осложняется геморрагическим экссудативным (выпотным) плевритом и на 2—3-й сутки заканчивается смертью. Обильное отхаркивание серозно-кровянистой, свертывающейся при стоянии мокроты (малиновое желе). В кровавой мокроте большое количество сибирезвездных палочек.

При кишечной форме налицо картина тяжелой общей интоксикации (общая резкая слабость, головная боль и головокружение, тошнота и рвота, режущие боли в животе, частый пульс), тяжелый геморрагический энтероколит; в рвотных и каловых массах много сибирезвездных палочек; иногда сильный парез кишечника с вздутием живота, сходный с непроходимостью кишок. Через 3—4 дня обычно наступает смерть.

**Распознавание.** При диагнозе всех форм сибирской язвы, помимо характерных клинических симптомов, большое значение имеет эпидемиологический анамнез с учетом профессии. Решающее значение имеет бактериологическое исследование (посев и прививка лабораторным животным крови, мокроты, кала, содержимого пузырьков и т. д.).

Кожная форма сибирской язвы отличается от простых поражений кожи (фурункул, карбункул, флегмопа), от рожи нерезко выраженной гиперемией, безболезненностью и быстрым развитием отека окружающей подкожной клетчатки. Легочная форма отличается от крупозной пневмонии быстро развивающейся тяжестью процесса и нахождением в кровянистой мокроте сибирезвездных бацилл; играет роль и анамнез (тряпичник, меховщик). Кишечная форма отличается от дизентерии сильными болями в животе, отсутствием жидкого стула и ранним падением пульса.

**Лечение.** Раннее введение (подкожно, внутримышечно, а в тяжелых случаях и внутривенно) 50—100 мл противосибирезвездной сыворотки; через 12—24 часа при отсутствии явных признаков улучшения болезни вторично вводится сыворотка в тех же дозах или проводится лечение пенициллином. В тяжелых случаях сывороточное лечение сочетают с внутривенным вливанием поваренного по 0,6 один риз в 5 дней. При падении сердечной деятельности — впрыскивание камфоры и кофеина. Местно — сухая стерильная или смоченная раствором перекиси марганца повязка.

**Профилактика.** Борьба с сибирской язвой среди животных. Прекращение вывоза шкур и шерсти животных из пораженных районов. Трупы павших животных сжигают или хоронят в земле на глубине не менее 2 м, насыпая на дно могилы и поверх трупа слой негашеной извести толщиной в 15 см. Подозрительный на сибирскую язву материал (кожа, мех, шерсть и т. д.) исследуют на реакцию Ас кол и (реакцию преципитации). Разобшение больных сибирской язвой. Длительное кипячение посуды больных, сжигание перовязоч-

ного материала. Выделения больных (мокрота, кал) заливают 5% раствором лизола или 10% раствором хлорной извести. Выписка выздоровевших производится после полного исчезновения клинических признаков болезни и двукратного отрицательного бактериологического исследования кала, мочи и других выделений. Медицинское наблюдение за лицами, соприкасавшимися с больными в течение 8 дней. В настоящее время разработан метод активной иммунизации людей вакциной.

**СКАРЛАТИНА (SCARLATINA).** Возбудитель, по мнению одних, — гемолитический стрептококк, по мнению других, — фильтрующий вирус. Инфекция передается от больного человека капельным путем и через предметы; чешуйки шелушения, особенно с рук, могут быть заражены тем же капельным путем. Очень важную эпидемиологическую роль играют реконвалесценты, у которых отмечаются патологические явления на миндалинах, в носу и в носоглотке; их следует приравнять к активным бациллоносителям. Подобно чешуйкам шелушения, оседанием мельчайших капелек инфицируются различные предметы и люди, находившиеся в контакте с больным. Таким образом, передача инфекции может совершаться путем как прямого, так и непрямого контакта (зараженные предметы, посуда, третье лицо).

**Симптомы и течение.** Инкубационный период длится 2—14 дней. Болезнь характеризуется внезапным началом — рвотой; в первый же день появляется ангина и сыпь, характерны огненная краснота мягкого неба, припухшие миндалины и наклонность к некротическим налетам. Мелкоточечная яркокрасная сыпь наиболее выражена на бедренном треугольнике и на сгибательных поверхностях конечностей. На лице отмечается резкое побледнение носогубного треугольника (треугольник Филатова). Высокая температура держится 9—11 дней и литически медленно падает. Ангина и сыпь постепенно бледнеют. На 5-й день болезни язык становится малиновым (резко припухшие сосочки). К концу 2-й недели начинается пластинчатое шелушение кожи, особенно выраженное на пальцах рук. Частые осложнения отмечаются на 4-й неделе болезни: воспаление большей частью шейных узлов, воспаление среднего уха и нефрит. Токсическая форма скарлатины протекает необычайно бурно с первых же часов заболевания: температура 40° и выше, частая рвота, потеря сознания, бред, судороги, нередко менингеальные симптомы. Септическая форма протекает с первых дней с гнойными осложнениями. Скарлатинозный токсин действует непосредственно на центральную нервную систему и в тяжелых случаях вызывает гиперемии мозга, мозговых оболочек и серьезное пропитывание коры головного мозга (лихорадка центрального происхождения, тахикардия, рвота, затемнение сознания, судороги). Воспалительный экссудат повсюду богат фибрином и клеточными элементами, вследствие чего для скарлатины характерны некротические и гнойные процессы.

Сыпь, покрывающая все тело, состоит из мелких, приподнятых над уровнем кожи элементов, расположенных на фоне общей гиперемии. Диагноз выраженной скарлатины можно легко поставить, если больной рано попадает под наблюдение. В сомнитель-

ных случаях каждый последующий день стирает симптомы, имевшиеся еще накануне.

**Распознавание.** На основании характерных клинических признаков и эпидемиологического анамнеза. Существует реакция погашения сыпи (Шульца-Чарльтона): сыворотка (или кровь) реконвалесцента, введенная в дозе 0,1—0,2 мл в кожу на месте свежей скарлатинозной сыпи, вызывает бледное (вследствие исчезновения сыпи) пятно диаметром около 5—6 см. В зависимости от входных ворот инфекции, различают еще раневую, ожоговую и послеродовую скарлатину (экстрабуккальную).

При скарлатине исключаются: сливная форма кори (отсутствие катарральных явлений, пятен Филатова-Коплика и наличие яркой ангины и некрозов); краснуха (отсутствие увеличения затылочных желез и наличие ангины и скарлатинозного треугольника на лице); сыпной тиф (наличие ангины и треугольника и отсутствие тяжелого тифозного состояния); сывороточная сыпь (наличие ангины и отсутствие увеличения регионарных лимфатических узлов вблизи от места введения сыворотки) и медикаментозные сыпи (наличие ангины и сосочковый язык).

**Лечение.** В токсических случаях назначают внутримышечное введение антитоксической скарлатинозной сыворотки в количестве 15 000—20 000 АЕ. При септических формах — стрептоцид, пенициллин внутримышечно по 10 000—20 000 единиц через 3—4 часа, особенно при развивающемся мастоидите, диета: в лихорадочном периоде молочно-растительная с достаточным количеством сахара и витаминов, при нефрите — бессолевая. Тщательный уход, исследование мочи каждые 5 дней. Перед выпиской из больницы необходимо отсутствие контакта с больными свежей и осложненной скарлатиной в течение 5—7 дней. При выписке больного ребенка необходимо инструктировать родителей об опасности контакта реконвалесцента с окружающими. В детские учреждения выписанные допускаются через 12 дней после осмотра врачом.

**Профилактика.** Изоляция (разобщение) больных на 30—40 дней (см. *Сроки изоляции*); карантин для окружающих, посещающих детские коллективы и не болевших скарлатиной, устанавливается на 12—21 день после разобщения с больным. Задержка выписки выздоровевших при наличии воспалительных явлений в зеве, носу и глотке.

Для суждения о восприимчивости к скарлатине пользуются реакцией Дика; при введении внутрикожно 0,1—0,2 мл токсина гемолитического скарлатинозного стрептококка у восприимчивых к заболеванию появляется воспалительная реакция. Применяются прививки скарлатинозным токсином: первое впрыскивание — 500 кожных доз, второе — 2 000 доз, третье — 6 000 доз, четвертое — 20 000 доз и пятое — 30 000 доз для детей старше 5 лет. При прививке против скарлатины между инъекциями назначаются следующие промежутки: между 1-й, 2-й и 3-й, а также между 4-й и 5-й в 7—15 дней, между 3-й и 4-й — в 10—15 дней. Прививки проводятся по эпидемическим показаниям с разрешения областного здравоотдела.

**СТОЛБНЯК (TETANUS).** Возбудитель — палочка столбняка, находящаяся в почве, куда она попадает с испражнениями лоша-

лей и коров. Заражение человека происходит при загрязнении рш земель (на войне, при полевых и огородных работах). Особенно олагодриятны для развития столбняка раздробленные, размозженные, глубокие колотые раны, раны нижних конечностей и отморожения третьей степени.

**Симптомы и течение.** Инкубационный период в среднем длится 6—14 дней, по иногда затягивается до 84 дней. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее форма заболевания. Достигнув центральной нервной системы, токсин оказывает резко возбуждающее действие на двигательные центры, что выражается в появлении судорог в группе мышц, ближайших к месту ранения. Мышцы живота тверды, как доска.

Отмечается затрудненное открывание рта вследствие судороги жевательных мышц (тризм), судорога мышц лица, характерное выражение лица при сморщенном лбе и приподнятых бровях — мучительная ироническая, так называемая сардоническая улыбка; затем появляется судорожное сведение мышц затылка и спинных мышц, выгибание тела дугой; голова запрокинута назад (opisthotonus). Температура часто повышена. Сознание сохранено. Приступы судорог от 10 до 30 раз в час, в зависимости от тяжести болезни. Эти приступы могут наступать под влиянием малейших внешних раздражений (стук, шум и прикосновении). Во время судорог больной обливается потом, стонет от сильнейших болей в мышцах. Смерть наступает при явлениях паралича дыхательных мышц. Чем тяжелее протекает столбняк, тем чаще и продолжительнее приступы общих судорог. Во время приступов могут произойти разрывы прямых мышц живота и m. ileo-psoas, разрыв селезенки, остановка дыхания.

**Р а с п о з и а в а н и е.** На основании характера ранения и типичных клинических симптомов.

Столбняк отличается: 1) от менингита — отсутствием рвоты, помрачения сознания, наличием тризма и судорог мышц; 2) от бешенства — отсутствием возбуждения психики и спазма глоточных мышц; 3) от тетании — отсутствием типичного положения кистей (руки акушера).

**Лечение.** Тщательная обработка раны (широкое раскрытие раны, удаление инородных тел и омертвевших участков тканей) и своевременное введение противостолбнячной сыворотки внутримышечно в дозе 25 000—50 000 АЕ; часть сыворотки рекомендуется вводить интратрахеально (внутринознично). Сыворотка вводится ежедневно до прекращения приступов. За 3 часа до введения сыворотки рекомендуется выпрыснуть 2 мл столбнячного анатоксина, через 5 дней — повторно 2 мл и еще через 5 дней — 4 мл. Лекарства: клизмы из хлоралгидрата (по 1,0—2,0 на клизму) и внутримышечно по 20 мл 10% раствора сернокислой магнезии в период сывороточного лечения. При невозможности кормления следует вводить жидкую пищу через нос при помощи тонкого зонда, предварительно смазав слизистую носа раствором новокаина. Rp. Chlorali hydrati 3,0 Dcocti amyli 100,0 MDS. На 2 клизмы

Из наркотиков лучший эффект дает парколан (0,1 на 1 кг веса) ректально в клизме в 2% растворе в воде температуры 38—41°.

**П р о ф и л а к т и к а.** При всяком ранении в случае загрязнения рапы пылью, почвой и землей пострадавшему немедленно вводят противостолбнячную сыворотку в количестве 3 000 АЕ (пассивная иммунизация); за 15 минут до впрыскивания сыворотки вводят 1 мл столбнячного анатоксина и через 2 недели повторно еще 2 мл. Активная иммунизация состоит в двукратных прививках столбнячным анатоксином (первый раз в количестве 1 мл и через 20 дней — 2 мл).

В настоящее время столбнячный анатоксин прививается в сочетании с брюшнотифозной вакциной. Активная иммунизация анатоксином здоровых людей должна проводиться среди определенных контингентов (землекопы, дорожные рабочие и др.).

**СЫПНОЙ ТИФ (TYPHUS EXANTHEMATICUS).** Возбудитель — риккетсии Провачека. Источник инфекции — больной человек, от которого платяные вши, насосавшись крови, содержащей риккетсии, передают их здоровому человеку. Сыпной тиф входит в группу риккетсиозов — заболеваний, распространенных в различных частях света, передаваемых кровососущими паразитами и протекающих с выраженной температурной реакцией и с образованием специфических изменений в мелких кровеносных сосудах.

Зараженные вши выделяют риккетсии с испражнениями. Заражение человека происходит путем втирания раздавленных зараженных вшей и их испражнений в кожные расчесы.

**Симптомы и течение.** Инкубация — 8—20 дней, начало болезни острое, с сильной головной болью и познабливанием. Лицо и конъюнктивы глаз гиперемированы (кроличье лицо). Температура сразу достигает высоких цифр, состояние больного возбужденное. На 4—5-й день на боковых поверхностях грудной клетки и локтевых сгибах появляется многообразная розеолезная глубоко сидящая сыпь\* которая через 1—2 дня превращается в петехии (точечные кровоизлияния).

Через 2—3 дня она распространяется по всему туловищу и на конечностях. Сознание часто затемнено, отмечается бред. Язык при высовывании как бы спотыкается (симптом Годелье). Селезенка увеличена, мягка наощупь. Умеренный лейкоцитоз в крови. Нарастающее падение кровяного давления, учащение пульса и глухие тоны сердца. Выделение мочи и потоотделение значительно уменьшаются. Лихорадка держится 14—16 дней и заканчивается растянутым кризисом (в течение 2—3. дней). В тяжелых случаях геморрагическая сыпь, явления менинго-энцефалита. Наиболее частые осложнения: пневмония, гангрена нижних конечностей, тромбозы, полиневриты, паротиты.

**Р а с п о з и а в а н и е.** По клиническим признакам (характерная сыпь на 4—5-й день болезни) и анамнезу (сыпнотифозный очаг). Для уточнения диагноза производится реакция Вейль-Феликса — реакция агглютинации сыворотки крови больного с палочкой протей X<sub>19</sub>. Положительной реакцией делается после 7-го дня болезни при разведении не ниже 1 : 200; -большое значение имеет нарастание титра до 1 : 800 —

1 : 1 600 и т. д. Имеются упрощенные и ускоренные методы реакции Вейль-Феликса. По Ноблю, реакция получается после 5-минутного встряхивания равной смеси (по 2 капли), разведенной в 5—20 раз сыворотки с чистой бактериальной взвесью протей  $X_{19}$ . По Минке-вичу, кровь больного с взвесью культуры смешивается не в пробирке, а на предметном стекле. Можно сделать реакцию Вейгля: материалом для реакции служит взвесь убитых фенолом риккетсий, добытых путем растирания стеклянной палочкой кишечников сыпнотифозных вшей, и сыворотка больного.

Сыпной тиф отличается: 1) от брюшного тифа (ранним появлением розеолезно-петехиальной сыпи, гиперемией лица и конъюнктивы, возбуждением психики и быстрым темпом развития болезни); 2) от возвратного тифа (наличием сыпи и отсутствием плотной, резко увеличенной селезенки и болей в икроножных мышцах); 3) от кори (отсутствием катарральных явлений и пятен Филатова-Коплика); 4) от скарлатины (отсутствием ангины и треугольника на лице).

**Лечение.** Симптоматическое: внутривенное введение 40% глюкозы по 30—50 мл; средства, повышающие кровяное давление: адреналин (1 : 1 000), эфедрин 5% по 0,5 мл под кожу 2 раза в день; впрыскивание камфоры, кофеина. При менингеальных признаках<sup>1</sup> — спинномозговой прокол. Тщательный уход за полостью рта, за кожей (предупреждение пролежней). Частое питье. Питание главным образом молочно-растительное, измельченное мясо, фруктовые и другие витаминные соки.

В последнее время при лечении сыпного тифа применен новый синтетический антибиотик — левомпцетин. Подробно см. главу XVII, *Фармакологические сведения, Лесомпцетин*.

**Профилактика.** Раннее помещение больных в больницу (не позже 5-го дня болезни). Санитарная обработка очага (стрижка, бритье, смена белья и его дезинсекция) и систематическое наблюдение за ним в течение 71 дня<sup>1</sup>. Борьба со вшивостью: дезинсекция помещения дустом ДДТ, 10% раствором мыльно-сольвентной смеси, 10% раствором альбихтоловой пасты (вещи складываются в мешок, смоченный этими же растворами), обработка волосистой части тела альбихтоловой пастой или мыльно-керосиновой эмульсией, а после мытья протереть 2% эмульсией мыла К. Предохранительные прививки сыпнотифозной вакциной (троекратно с промежутками в 5 дней в дозах 0,5—1—1 мл). Выписка больного из больницы производится через 10—12 дней после падения температуры.

**ТУЛЯРЕМИЯ.** Возбудитель — палочка туляремии. Резервуар вируса — грызуны: водяные крысы, мыши (полевые, лесные и домашние), кролики, зайцы, суслики и др. Инфекция передается человеку или непосредственно при соприкосновении с больными животными (охота), через зараженные пищевые продукты и воду, реже при вдыхании пыли (при обмолоте хлеба, работе в зернохранилищах, в картофелехранилищах), или передатчиками — кровососущими насекомыми (слепень, клещ, комар и др.).

<sup>1</sup> В расчет принимаются максимальные сроки: 1) циркуляция вируса в крови больного (возможность заражения вшей) — 20 дней; 2) продолжительность жизни зараженных вшей (возможность заражения людей) — 30 дней; 3) инкубационный период — 21 день.

**Симптомы и течение.** Инкубационный период — от 1 до 21 дня, в среднем 8 дней. Жалобы на мышечные боли, общую разбитость и головную боль. Появление узелка (на месте внедрения инфекции) с последующим образованием язвочки; припухание и болезненность регионарных (ближайших) лимфатических узлов, частое нагнаивание их; быстрое повышение температуры с ознобом.

Различают следующие формы туляремии: 1) тифоподобную без паружной локализации с продолжительной температурой, 2) железистую (бубонную) с подразделением на язвенно-железистую, ангинозно-железистую (с поражением миндалин и с припуханием шейных желез), глазо-железистую (с поражением конъюнктивы и припуханием ближайших лимфатических узлов), 3) бронхоульмональную или легочную форму. Температура неопределенная, нередко перемежающаяся, ослабляющая и волнообразная. Основные формы: бубонная и тифозная.

Картина крови: лейкопения с лимфоцитозом, моноцитоз, сдвиг умеренный влево.

При железистой форме — первичные бубоны и вторичные в различных местах вплоть до образования мезентериальных бубонов (абдоминальная форма). При тифоподобной форме — лихорадка держится около 2—3 недель и часто появляются различные высыпания. Легочная форма — также затяжная тиг- бронхопневмонии, с припуханием бронхиальных лимфатических узлов.

Сердечно-сосудистые изменения находятся в зависимости от степени общей интоксикации.

**Распознавание.** На основании эпидемиологического анамнеза и клинических характерных признаков, бактериологического исследования (посев крови и пунктата железы после предварительного пассажа материала через морскую свинку или белую мышь, реакция агглютинации после 10-го дня болезни), внутри-кожной пробы с тулярином (более ранняя диагностика). Тулярин вводится внутрикожно в объеме 0,1 мл туберкулиновым шприцем. При положительной реакции (через 24—48 часов) на месте укола появляется гиперемия, отек и нередко ограниченный некроз.

Туляремия отличается: от чумы — отсутствием спаянности бубонов с соседними тканями, малой болезненностью их и сравнительно удовлетворительным общим состоянием; от сибирской язвы — отсутствием темного струпа в центре и отека подкожной клетчатки; от дифтерийной и других видов ангин — характером налета и увеличением регионарных желез — без отека подкожной клетчатки. Легочная форма отличается от туберкулезного бронхаденита плотностью бронхиальных желез и преимущественным поражением бронхов.

**Лечение.** На кожные язвы накладывают местно серую ртутную мазь, на бубоны — местно тепло. Специфическое — вакцинация начиная с 0,1 мл (5 млн. микробных тел). Через 5 дней дозу увеличивают на 0,1 мл (5—7 инъекций). В острых случаях назначают стрептоцид и сульфидин в больших дозах (до 3,0 в сутки). Переливание крови (200—250 мл). При нагноении лимфатических узлов — разрез.

**Профилактика.** Борьба с грызунами. Для истребления грызунов применяют фтористый натрий и углекислый барий в виде затрав. Активная иммунизация живыми авирулентными штаммами *V. tularensae* подобно оспопрививанию. Охрана пищевых продуктов и водоемов от загрязнения грызунами. Ранний обмолот зерна; индивидуальная защита при работе с зараженными скирдами (очки, перчатки). Кипячение воды из зараженных водоемов.

**ХОЛЕРА АЗИАТСКАЯ (CHOLERA ASIATICA).** Возбудитель холеры — вибрион Коха — имеет вид запятой, снабженной жгутом. Источник инфекции — больной холерой человек и переболевший носитель. Холерный вибрион передается пищей, водой и через выделения больных. Водный фактор в эпидемиологии холеры играет главную роль. Его можно выделить из рвотных и каловых масс больных посевом на 1% пептонную воду.

**Симптомы и течение.** Инкубационный период длится от нескольких часов до 3—5 дней. В легких случаях отмечается понос, к которому вскоре присоединяется рвота (холерина). Огромные массы жидкости извергаются с поносом и рвотой, что приводит к высушиванию тканей и сгущенной крови. В тяжелых случаях различают два периода: алгидный (холодный) и тифоидный.

Симптомы начального (алгидного) периода холеры — обильные и частые рвоты и понос, ведущие к резкому обезвоживанию организма. Типичные испражнения в виде водянистых мутных, напоминающих рисовый отвар, выделений. Характерен внешний вид больного: заостренные черты лица, кожа сухая, легко берущаяся в складки, холодная наощупь, цианотичная. Температура падает до 35—34°, пульс частый, нитевидный, появляются судороги. Язык сухой, обложен густым налетом, появляется сильная жажда, причем каждый новый прием воды сопровождается извержением жидкости обратно. Сознание сохранено, наступает резкая слабость, кожа покрывается липким потом, взгляд тускнеет, теряется звучность голоса. При явлениях резкого падения сердечной деятельности больные погибают. Если больной выживает, алгидный период может перейти в тифоидный, характерные признаки\* которого: резкий подъем температуры — до 40—41°, лицо гиперемировано, появляется бред; основной симптом — нефрит с явлениями азотемической уремии, от которой больной и погибает.

Сухая холера протекает без поноса, смерть наступает от интоксикации до развития кишечных явлений. Молниеносная холера протекает при типичной картине быстро развивающегося алгида и заканчивается смертельным исходом в течение нескольких часов.

**Распознавание.** Важны бактериологические исследования испражнений и рвотных масс. Материал собирается в специальную банку с крышечкой и немедленно отправляется со всеми предосторожностями в лабораторию.

Холера отличается: от острейших форм паратифозных токсикоинфекций (мясных отравлений), протекающих в форме тяжелых гастроэнтеритов (*cholera nostras*), от отравления ядовитыми грибами и мышьяком. Здесь решающее значение имеет бактериологическое исследование каловых и рвотных масс на наличие холерного вибриона.

**Лечение.** Ввиду сильного обезвоживания организма немедленно внутривенные вливания больших количеств физиологического раствора (по 3—5 л несколько раз в день) или, еще лучше, гипертонического раствора соли (по 1—1,5 л несколько раз в день). Применяют внутривенно по 0,5—1 л 1,5—3% *Natrii carbonici*. Перед вливанием растворы подогреваются до 42°. Вливание производится медленно (в течение 10—15 минут) через аппарат Боброва. Можно также внутривенно ввести 5% глюкозу в количестве 500 мл. Мощным средством в алгидном периоде является также переливание крови (до 500 мл в один раз). Большое значение имеет согревание организма грелками, теплыми ваннами (35—36°). Впрыскивание камфоры и кофеина. Специфическим средством является холерный бактериофаг по 10—20 мл на воде маленькими дозами 2 раза в день в течение 3 дней. Диета — молочная и молочно-растительная, нища в протертом виде, фруктовые соки, витамины. Строгий постельный режим и гигиенический уход.

**Профилактика.** Немедленно помещение в больницу больных и подозрительных на холеру. При обнаружении хотя бы одного случая холеры каждый случай поноса в данной местности должен подвергаться бактериологическому исследованию. Строгая дезинфекция выделений больных, помещений и уборных хлорной известью, лизолом, хлорамином и др. Питьевая вода должна быть под тщательным бактериологическим контролем. Окружающие больного лица должны быть подвергнуты обследованию и карантину на 6 дней. Выписка больных производится после трехкратного отрицательного исследования кала с последующим наблюдением на дому в течение 6 месяцев на бацилловыделение.

Для иммунизации соприкасавшихся с больным холерой применяется бактериофаг (по 10—15 мл натошак). Большое значение имеют противохолерные прививки моновакциной из убитых холерных вибрионов (3 инъекции по 0,5—1—1 мл с промежутком в 7—10 дней) или с тетравакциной (брюшнотифозная — паратифозная А и В).

**ЧУМА (PESTIS).** В СССР чумных очагов нет, но занос чумы из-за рубежа возможен. Возбудитель — палочка чумы характерной бочонкообразной формы, окрашивающаяся на концах. Хранители чумной заразы — грызуны (крысы, суслики, тарабаганы и др.), от которых человек заражается или непосредственно (при обработке шкур грызунов, во время охоты за ними), или через укусы блох, паразитирующих на, больных грызунах. От человека к человеку зараза передается через зараженные вещи или капельным путем (легочная чума). -

Различают две клинические формы чумы: бубонную и легочную.

**Симптомы и течение.** Инкубация 3—5 дней. Начало болезни острое с высокой температурой, сильной головной болью, шатающейся походкой, язык покрывается известково-белым налетом.

При бубонной форме резкая боль в области пораженных лимфатических узлов, чаще паховых, а у детей — подмышечных и шейных, постепенное припухание их. Быстрое развитие геморрагического некротического воспаления; узлы спаиваются между собой, с прилегающей кожей и подкожной клетчаткой, образуя большие

пакеты (бубоны); кожа лоснится, краснеет, впоследствии изъязвляется и бубон вскрывается наружу. В геморрагическом экссудате (кровянистом выпоте) находится большое количество палочек чумы. В тяжелых случаях — септицемия с образованием вторичных бубонов и частым осложнением вторичной чумной пневмонией. Резкая тахикардия (до 120—160 ударов), понижение кровяного давления. На коже может быть кровянистая и гнойная сыпь. Температура соответствует тяжести процесса. Смерть наступает от слабости сердца. При легочной форме (первичной) чумы развивается геморрагическое воспаление с некрозом мелких легочных очагов. Это самая опасная форма чумы — смертность до лечения стрептомицином в комбинации с серотерапией и сульфидином достигала почти 100%. Рано развивается сильная одышка, цианоз (синюха), боль в груди, кашель с кровянистой мокротой, содержащей большое количество палочек чумы. Температура очень высокая, пульс частый, слабого наполнения, тоны сердца глухие. Болезнь обычно длится 4—5 дней и заканчивается смертью. Иногда присоединяется тяжелая септицемия с геморрагическими явлениями в коже, кровавой мокротой и кровавой рвотой.

**Распознавание.** Эпидемиологический и клинический анамнез (развитие болезни, развитие бубона). Точный диагноз ставится бактериологическим исследованием содержимого бубона (бактериоскопически и путем посева на среды), мокроты (при легочной форме) и крови на чумные палочки. Надо помнить о высокой заразительности исследуемого материала. Чума отличается от туляремии быстротой развития токсических явлений и болезненностью бубонов; от других лимфаденитов — теми же признаками и главным образом эпидемиологической обстановкой.

**Лечение.** Специфическое: большими дозами (от 50 до 100—200—300 мл) противочумной сыворотки под кожу, внутримышечно, в тяжелых случаях и внутривенно. Сыворотка вводится повторно несколько раз через день до благоприятного перелома болезни. Одновременно с противочумной сывороткой вводится хлористый кальций. При легочной форме дополнительно к сывороточному лечению и сульфидину применяется стрептомицин (Н. Н. Жуков-Вережников и др.). Применяется также чумный бактериофаг по 5—10 мл внутримышечно или внутрибубонно. Можно сочетать серотерапию с фаготерапией. Сердечные средства — впрыскивание камфоры, кофеина, кардиазола, адреналина, дигалена и строфанта. Местно — серая ртутная мазь. Больные выдерживаются не менее 1 месяца со дня клинического выздоровления.

**Профилактика.** Энергичная борьба с грызунами, особенно с крысами; дезинфекция и дезинсекция. Карантинизация судов и людей, прибывающих из не благополучных по чуме местностей. Личная профилактика: работа в масках при уходе за больными легочной чумой, в специальной прозодежде (противочумные костюмы). Строгая регистрация каждого случая чумы. Предохранительные прививки по методу Покровской — авирулентной живой культурой падоцки чумы, обработанной чумным бактериофагом.

**ЭНЦЕФАЛИТ (ENCEPHALITIS). ВОСПАЛЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА.** Может быть первичное и вторичное. Первичное воспа-

ление мозга вызывается вирусами — летаргический, весенне-летний (клещевой), осенний (комариный), вторичное наблюдается при общих инфекционных заболеваниях.

**А. Летаргический энцефалит.** Начинается медленно: незначительное повышение температуры, головная боль, головокружение, двоение в глазах, нарушение сна (бессонница или сонливость, иногда бессонница ночью, а днем сонливость). Нередко спустя некоторое время после острого периода (недели, месяцы или даже годы) развивается хроническая стадия: общая скованность, заторможенность, амимия, саливация, медленная речь, монотонный голос, дрожание в пальцах рук — **п а р к и н с о н и з м**. У детей в этом периоде отмечается изменение поведения: раздражительность, неуживчивость, злобность, склонность к бродяжническому.

**Распознавание.** Базируется на типичной клинической картине (расстройстве сна, параличи глазных нервов, гиперкинезы).

В хронической стадии следует исключить болезнь Паркинсона, которая встречается в возрасте 50 лет и старше (см. **П а ^ а л и ш ^ < \_ д р о - ^ и с а т е м н ы й ^**).

В остром периоде — внутривенно 5—8 мл 40% уротропина, сыворотка выздоравливающих (50 мл), 10% йодистый натрий внутривенно, оксигенотерапия (подкожно ежедневно в течение 10 дней по 300 мл кислорода). При паркинсонизме скополлами, белладонна, корень болгарской красавки, при сонливости — фенамин.

**В. Весенне-летний энцефалит.** Болезнь развивается в последние весенние и первые летние месяцы. Вирусное заболевание, передатчиком которого является клещ. Инкубационный период 12—14 дней. Начинается остро — высокая температура, головная боль, менингеальный синдром, судороги, параличи. Встречаются молниеносные формы, когда смерть наступает в течение первых суток заболевания. К остаточным явлениям относятся судороги и эпилептические припадки.

**Распознавание.** Необходимо исключить острый полиомиелит, строго учитывать развитие болезни и эпидемиологию.

**Лечение.** Введение сыворотки выздоравливающих, внутривенное введение 40% уротропина, внутримышечное введение витамина В<sub>1</sub>. При парезах и параличах — прозерин, физиотерапия. **П р о ф и л а к т и к а .**

Уничтожение клещей, вакцинация работающих в тайге, ранняя изоляция заболевших.

**В. Осенний комариный энцефалит.** Возбудитель — вирус, передается комарами. Заболевание сезонное — появляется в конце лета и осенью. Инкубационный период длится 10—15 дней. Начинается внезапно: высокая до 41° температура, головные боли, сумеречное и галлюцинаторное состояние, общее беспокойство, судороги, эпилептиформные припадки, параличи. Продолжительность острого периода 7—12 дней.

**Лечение.** Такое же, как и при клещевом энцефалите. Профилактика базируется на борьбе с комарами и их укусами, ранней изоляции больных и дезинфекции окружающих предметов.



Г. Вторичные энцефалиты. Возникают как осложнение общих инфекций (грипп, малярия, пневмония, корь, коклюш, дизентерия, тифы, ветряная оспа и др.). Особенно часто встречаются в детском возрасте.

**Симптомы.** Начинаются остро или подостро. Незначительное повышение температуры длится несколько дней, иногда отмечается бредовое состояние, судороги, параличи, поражение череп-нозговых нервов. В качестве остаточных явлений наблюдаются эпилептические припадки, ограниченные судороги, парезы, параличи, отсталость умственного развития.

**Лечение основного заболевания.** При остаточных явлениях — физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, йодистые препараты, общеукрепляющее лечение, бромистый кальций.

Rp. Scopolamine hydrobromici 1:1000 Sol. Atropini sulfurici 1:1 000 Sol. Morphini hydrochlorici 1:100 aa 5,0 MDS. По 3—5 капель 2 раза в день

Rp. Decorti Vini radices Atropae Belladonnae 5% 100,0 DS. По  $\frac{1}{2}$  чанной ложки на ночь

Rp. Phenamini 0,01 Sacchari 0,2 M. f. **pulv.** N. 20 DS. По одному порошку перед сном

**ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ПАРОТИТ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ (PAROTITIS EPIDEMICA). СВИНКА-ЗАУШНИЦА.** Возбудитель — фильтрующий вирус. Передача инфекции от больного здоровому капельным путем.

**Симптомы и течение.** Инкубация 14—21 день. При умеренно повышенной температуре появляется боль при жевании и опухание слюнных желез, чаще околоушных — сначала передней доли (впереди уха), потом задней (за углом нижней челюсти).

Опухоль желез не очень плотной консистенции, болезненна. Железы нагнаиваются редко. Небольшая гиперемия зева, покраснение и разрыхление отверстия стенонова протока. Иногда сильный отек слизистой оболочки зева с затруднением глотания. Через 5 дней температура быстро падает, опухоль постепенно исчезает к 7—8-му дню болезни. Нередко болезнь перебрасывается из одной слюнной железы в другую и может затянуться на несколько недель. Осложнения: часто у подростков орхит с возможной атрофией яичка; у девочек воспаление грудных желез и яичников, редко поражение внутреннего уха и глухота.

**Распознавание.** В выраженных случаях на основании характерной припухлости околоушной железы.

**Лечение.** Местно — тепло, постельный режим на все время лихорадочного периода. Жидкая пища. В тяжелых случаях сыворотка выздоравливающих (в дозе 3—8 мл). Стрептоцид по 1,0—2,0 в день равными дозами.

**Профилактика.** Изоляция больных. Больной считается заразным до 14 дней по исчезновении клинических явлений. Карантин на 3 недели для здоровых, бывших в соприкосновении с больным.

**ЯЩУР (ARHTNAE ERIZOOTICAE).** Возбудитель — фильтрующий вирус. Болеют ящуром парнокопытные животные — крупный и мелкий рогатый скот. Люди заражаются при контакте с больными животными или при употреблении в пищу зараженных сырых молочных продуктов. Вирус проникает через кожные повреждения и слизистые рта и глотки.

**Симптомы и течение.** Инкубация — около 10 дней. Повышенная температура, чувство жжения во рту; гиперемия слизистой оболочки рта и на этом фоне болезненные белесоватые пузырьки. Пузырьки лопаются и образуются язвочки с сероватым дном и красными краями. Обильное слюнотечение и припухлость шейных желез. Такие же пузырьки и язвочки могут образоваться на складках кожи между пальцами и у выходного отверстия мочеиспускательного канала.

**Лечение.** Смазывание и полоскание рта растворами перекиси водорода (2—3%), буры (3%), новарсенол внутривенно — по 0,3—0,45.

**Профилактика.** Борьба с заболеваемостью ящуром среди рогатого скота. Запрещение употреблять " пищу сырые молочные продукты,

/\*

## Добавление I

## СРОКИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА

| Название болезни                        | Сроки инкубационного периода (в днях) |              | 1     | 2   | 3               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|-----|-----------------|
|                                         | средние                               | максимальные |       |     |                 |
| Брюшной тиф.....                        | 15 6                                  | мини-мальные | 4     | 10  | 5               |
| Паратиф Б.....                          |                                       |              | 4     | 3   | Несколько часов |
| » А.....                                |                                       | 7            | а     |     |                 |
| Токекоинфекции . . . .                  |                                       | 3            | с     |     |                 |
| Дизентерия бациллярная .....            | 3 3-7                                 | 2 2-3 часа   | а     |     |                 |
| Дизентерия амебная . .                  | 2-3                                   |              | 7     | 2   | 3               |
| Холера .....                            | 14                                    |              | 5     | 21  |                 |
| Сыпной тиф .....                        |                                       |              | 4     |     |                 |
| Возвратный тиф . . . .                  |                                       |              | 6     |     |                 |
| » » клеще                               |                                       |              | 2     | 4-7 | 3               |
| вой .....                               | 7 12                                  |              | 0     |     |                 |
| Малярия .....                           |                                       |              | 1     |     |                 |
| Москитная , лихорадка (паппатачи) ..... | 5 3-6                                 |              | 4     |     |                 |
| Скарлатина .....                        | 5                                     |              | 10    |     |                 |
| Дифтерия .....                          | 10 4/                                 |              | 3     |     |                 |
| Корь .....                              | 9 14                                  |              | 1     |     |                 |
| Коклюш .....                            | 10 18 2-                              |              | 11    |     |                 |
| Ветряная оспа .....                     | 3                                     |              | 10 18 |     |                 |
| Натуральная оспа . . .                  |                                       |              | 15 21 |     |                 |
| Эпидемический паротит                   |                                       |              | 15    |     |                 |
| » менингит                              |                                       |              | 30 7  |     |                 |
| Эпидемический энцефалит: клещевой ..... |                                       |              |       |     |                 |
| японский .....                          | 14 14                                 |              |       |     |                 |
| Полиоэнцефалит .....                    | 7                                     |              |       |     |                 |
|                                         | Несколько часов                       |              |       |     |                 |

Несколько  
о  
часов21-  
23

## Продолжение

| Сроки инкубационного периода (в днях)            |                  | Средние                                     |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Примечание                                       | Название болезни |                                             |
|                                                  | Сибирская язва   |                                             |
|                                                  | Сап .....        | 2 3-4                                       |
|                                                  | Бешенство        |                                             |
|                                                  | Грипп .....      |                                             |
|                                                  | Чума .....       | 14                                          |
|                                                  | Яшур .....       | 12 часов                                    |
|                                                  | Л .....          |                                             |
|                                                  | е                |                                             |
|                                                  | Т                |                                             |
|                                                  | у                | 7 40                                        |
|                                                  | л                | 4                                           |
|                                                  | о                |                                             |
|                                                  | я                | 7 21                                        |
|                                                  | с                |                                             |
|                                                  | п                |                                             |
|                                                  | и                | 7-Ю                                         |
|                                                  | р                |                                             |
|                                                  | е                |                                             |
|                                                  | м                |                                             |
|                                                  | и                |                                             |
|                                                  | о                |                                             |
|                                                  | з                |                                             |
|                                                  | я                |                                             |
|                                                  | ы                |                                             |
|                                                  | .                |                                             |
| При трехдневно й мал яр ип Б иногда 7-11 месяцев | р                |                                             |
|                                                  | у                |                                             |
|                                                  | ц                |                                             |
|                                                  | е                |                                             |
|                                                  | ш                |                                             |
|                                                  | м                |                                             |
|                                                  | л                |                                             |
|                                                  | а                |                                             |
| у привитых противокоревой сывороткой 28 дней     | л                |                                             |
|                                                  | е                |                                             |
|                                                  | и                |                                             |
|                                                  | з                |                                             |
|                                                  | о                |                                             |
|                                                  | з                |                                             |
|                                                  | .                |                                             |
|                                                  | ы                |                                             |
|                                                  | .                |                                             |
|                                                  | Б                |                                             |
|                                                  | о                |                                             |
|                                                  | т                | Столбняк                                    |
|                                                  | у                |                                             |
|                                                  | л                |                                             |
|                                                  | и                |                                             |
|                                                  | з                |                                             |
|                                                  | м                | Газовая гангрена (раневые инфекции) . . . . |
|                                                  | ..               |                                             |
|                                                  | .                |                                             |

| минимальные     | максимальные | Примечание                                                 |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Несколько часов | 3            |                                                            |
| <b>То же</b>    | 9-Ю          |                                                            |
| 1               | 21           | У вакцинированных и при введении сыворотки до 12 дней      |
| • 7             | недель       |                                                            |
| 1-2 часа        | 26           |                                                            |
| Несколько часов |              |                                                            |
| 3 15            |              |                                                            |
| 2 3-4           |              |                                                            |
| 10              | <b>14</b>    |                                                            |
|                 | <b>80</b>    |                                                            |
| 1               | <b>6</b>     | Редко до 1 года                                            |
|                 | <b>20</b>    |                                                            |
|                 | 9            |                                                            |
|                 | месяцев      |                                                            |
|                 | 36           | Иногда до 1 года и более (при операциях удаления осколков) |

**R  
O  
O  
N  
S  
Y  
E  
H  
E  
M**

| Заболевание             | Какой материал должен быть взят для лабораторного исследования                                                                                                                                                                                                                                                                                | На какой день от начала болезни                                                            | Когда лаборатория может взять заключение *                                  | Примечание                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брюшной тиф             | 1. Кровь (8—10 мл из вены) во флакон с 40—50 мл желчи или шпичного бульона для получения гемокультуры<br>2. Кровь (1—2 мл из вены или из пальца) в пробирку для реакции агглютинации<br>3. Кал (3—5 г в специальный патрон или стерильную баночку)<br>4. Моча (50—100 см <sup>3</sup> в стерильную бутылочку)                                 | С 1—2-го<br><br>С 8—9-го<br>С начала заболевания, но чаще с 3-й недели<br><br>С 3-й недели | Через 3 дня<br><br>На следующий день<br>Через 4 дня<br><br>То же            | Реакцию повторить через 5—7 дней<br><br>Смешать в патроне с равным объемом 30% глицерина в физиологическом растворе |
| Паратифы А и В          | 1. Кровь для получения гемокультуры, как при брюшном тифе<br>2. Кровь для реакции агглютинации<br>3. Кал и моча, как при брюшном тифе                                                                                                                                                                                                         | С 8—9-го дня                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |
| Пищевые токсикоинфекции | 1. Кровь на гемокультуру, как при брюшном тифе<br>2. Рвотные массы» 15—20 мл (в специальный патрон)<br>3. Кал (3—5 г в патрон или баночку)<br>4. Кровь для реакции агглютинации<br>5. Пищевые продукты (остатки готовой пищи, остатки сырого мяса, трубчатых костей, рыбы.)<br>6. Рекомендуется 5—6 мл крови из вены впрыснуть морской свинке | Со 2-го дня<br><br>Сразу<br>То же<br>С 8—9-го дня<br><br>С 1—2-го дня                      | Через 3 дня<br><br>Через 4 дня<br>То же<br>На следующий день<br>Через 4 дня | В глицериновой смеси                                                                                                |

|                                             |                                                                                                                   |                        |                                                                                      |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дизентерия ба-<br>циллярная                 | Кал (3—5 г в датроп или про-<br>бирку, выбирать слизисто-гнойные<br>комочки)                                      | С 1-го дня             | Через 4 дня                                                                          | Если возможно, посев<br>производить у постели<br>оольного                                                                                 |
| Холера азиат-<br>ская                       | 1. Рвотные массы }<br>2. Кал (3—5 г) } <b>н</b> специаль-                                                         | То же                  | Предваритель-<br>ное—через 12 ча-<br>сов; окончатель-<br>ное — через 36—<br>48 часов | Материал тщаельно<br>упаковать и опломбиро-<br>вать                                                                                       |
| Сыпной тиф                                  | 3. Два мазка из кала на пред-<br>метных стеклах<br>Кровь (1—2 мл из вены или<br>пальца) для реакции агглютинации  | То же                  | В тот же день                                                                        |                                                                                                                                           |
| Возвратный тиф                              | Кровь из пальца в виде двух<br>мазков и двух толстых капель на<br>предметных стеклах                              | С 5—7-го дня           | На следующий<br>день                                                                 | При получении низкого<br>титра реакцию повторить<br>через 3—5 дней                                                                        |
| Малярия<br>Дифтерия<br>Скарлатина<br>Ангина | То же<br>Пленку или слизь из зева (при<br>дифтерии и из носа) на стерильный<br>ватный тампон                      | Во время при-<br>ступа | В тот же день,                                                                       | Кровь брать только<br>при высокой температу-<br>ре, желательнo вечером                                                                    |
|                                             |                                                                                                                   | То жз<br>С 1-го дня    | То жз<br>На следующий<br>день •                                                      | Тампоны переслать в<br>лабораторию немедленно<br>после взятия материала.<br>Доставить немедленно.<br>Беречь от охлаждения                 |
| Эпидемический<br>менингит                   | Спинномозговая жидкость (5 —<br>10 мл, добытые при пункции, в<br>стерильной пробирке)                             | С 1-го дня             | <b>То жз</b>                                                                         | При необходимости<br>проведения биологиче-<br>ской пробы на живот-ных<br>лаборатория может<br>задейжмь выдачу ре-<br>зультатов на 3—4 дня |
| Сибирская язва:                             |                                                                                                                   |                        |                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Кожная форма                                | 1. Содержимое пузырька вокруг<br>язвочки на стерильном ватном<br>тампоне и на двух- предметных<br>стеклах (мазки) | <b>То жз</b>           | <b>То ж;</b>                                                                         |                                                                                                                                           |
| Легочная форма                              | 2. Мокрота в стерильном патро-<br>пе и два мазка мокроты на пред-<br>метных стеклах                               | То же                  |                                                                                      |                                                                                                                                           |



## СРОКИ ИЗОЛЯЦИИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЬНЫХ И СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С НИМИ

Утверждены Наркомздравом СССР 1/VIII 1940 г.

| Название болезни | Раздел I<br>Продолжительность срока изоляции лиц, перенесших заразные заболевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Раздел II<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, бывших в соприкосновении с заразными больными до момента изоляции больного                                                                                                                                                                                                                                                 | Раздел III<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, находящихся в общении с заразными больными в течение всего периода болезни при оставлении больного на дому *                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Брюшной тиф   | 1. Изоляция больного прекращается после двукратного отрицательного результата исследования испражнений и мочи на тифозную палочку. Первое исследование производится спустя 5 дней после исчезновения клинических симптомов. Повторные исследования производятся с пятидневными промежутками. Изоляция больного при невозможности производства бактериологического исследования прекращается не ранее | 1. Лица, имевшие общение с больными, разобщению не подлежат, но остаются под медицинским наблюдением в течение 30 дней с момента изоляции больного.<br>Лица, находящиеся под медицинским наблюдением, допускаются к продолжению своих обычных занятий, но должны показываться не менее одного раза в декаду для медицинского наблюдения и производства бактериологического исследования | Госпитализация больного обязательна. При оставлении больного на дому (с разрешения эпидемиолога) должно быть проведено следующее:<br>а) лица, проживающие в одной квартире с заболевшим, подлежат медицинскому наблюдению на все время болезни и в течение 30 дней после выздоровления;<br>б) лица, ухаживающие за заболевшим, допускаются к работе после выздоровления больного, |

В  
И  
К  
Б  
о  
и  
Е  
н  
и  
о  
н

\* Оставление на дому острозаразных больных, подлежащих обязательной госпитализации, допускается в исключительных случаях лишь с разрешения эпидемиолога, государственного санитарного инспектора или медицинского работника, их заменяющего, при наличии изолированного помещения для больного и отдельно ухаживающего персонала, полностью изолированного от окружающих.

Медицинским наблюдением называется такая форма медицинского надзора за реконвалесцентами, бациллоносителями и лицами, бывшими в контакте с заболевшим, при которой эти лица не изолируются и не подвергаются никаким стеснительным мерам. Эти лица допускаются к продолжению их обычных занятий, но находятся под наблюдением и в определенные сроки являются к врачу или фельдшеру (на фельдшерских пунктах) для производства соответствующих исследований. Кроме того, указанные лица обязаны исполнять все предписания относительно соблюдения необходимых санитарных правил личной гигиены. Эти лица при перемене местожительства обязаны уведомить соответствующую санитарно-эпидемиологическую организацию.



12 дней после исчезновения клинических симптомов, в частности, падения температуры до нормы.

2. Поотношению к работникам центрального водоснабжения, пищевой промышленности и общественного питания, а также по отношению к персоналу, обслуживающему лечебные детские учреждения, санатории и дома отдыха (сестры и няни), необходимо придерживаться следующих правил:

а) все поименованные работники, переболевшие брюшным тифом, без предварительного лабораторного контроля не допускаются в указанные учреждения и предприятия;

б) все поименованные работники, переболевшие брюшным тифом, допускаются на работу после клинического выздоровления и двукратного отрицательного исследования; в дальнейшем они остаются под медицинским наблюдением, при этом им производится исследование мочи и кала на брюшной тиф один раз в неделю в течение 17 месяцев после выписки из больницы;

в) лица, у которых установлен отрицательный результат бак-

испражнений и мочи на тифозную палочку. Эти лица должны исполнять все предписания врача относительно соблюдения необходимых санитарных правил личной гигиены.

2. Лица, обслуживающие предприятия и учреждения, перечисленные в разделе I, п. 2, бывшие в соприкосновении с больными, после изоляции больного допускаются к работе после двукратного отрицательного исследования (с обязательной дачей слабительного) кала и мочи и остаются под медицинским наблюдением в течение 30 дней.

проведения заключительной дезинфекции и однократного отрицательного исследования их с установлением за ними медицинского наблюдения в течение 30 дней после выздоровления больного;

в) лица, обслуживающие перечисленные в разделе I, п. 2 предприятия и учреждения, допускаются к работе только по выздоровлении больного, произведении заключительной дезинфекции с соблюдением правил, указанных в разделе II, п. 2.

О  
С  
Т  
О  
В  
Л  
Е  
Н  
И  
ЕW  
O  
U  
L  
D  
E  
X

\* К работникам пищевой промышленности и общественного питания относятся следующие категории: работники молочной промышленности (молочные фермы, сливные пункты, сыроварни и т. п.), работники по производству, переработке, продаже, распределению, транспортировке, хранению и заготовке продуктов питания и напитков, непосредственно соприкасающиеся с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией, работники по чистке и мойке производственного оборудования, инвентаря и тары, подсобные рабочие тех же предприятий по перевозке сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в незатаренном виде, все работники предприятий общественного питания (за исключением тех работников, которые по роду своей работы не посещают производственные цехи и не имеют непосредственного соприкосновения с сырьем и готовой продукцией).

Название  
болезни

Раздел I  
Продолжительность срока  
изоляции лиц, перенесших  
заразные заболевания

Раздел II  
Продолжительность срока  
и формы разобщения лиц,  
бывших в соприкосновении  
с заразными больными до  
момента изоляции больного

Раздел III Продолжительность  
срока и формы разобщения лиц,  
находящихся в общении с  
заразными больными в течение  
всего периода болезни при  
оставлении больного на дому

териологического исследования, допускаются к работе в этих учреждениях; однако в течение периода медицинского наблюдения (1/1! месяца) они не должны быть использованы на работе, связанной с питьевой водой, пищевыми и молочными продуктами, а также с непосредственным обслуживанием детей а больных;

г) при наличии положительного результата хотя бы при одной пробе соответствующие лица не допускаются на работу по специальности в течение дополнительных 2 месяцев и используются на работе вне центрального водопровода, пищевой сети, лечебных детских, учреждений, санаториев и домов отдыха;

д) все поименованные работники, переболевшие брюшным тифом, через 3/1, месяца после выздоровления подвергаются заключительному бактериологическому контролю (двукратному исследованию кала и мочи с перерывом в 5 дней).

Для лиц, дававших положительный результат при контроле, указанном в п. 2, лит. «в», дополнительно проводится одновременное исследование дуоденального содержимого.

ВОЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  
ЛЕКСИКОНЪ,

При отрицательном результате заключительного контроля эти лица допускаются к работе по своей специальности. Обнаружение тифозных бактерий у названных лиц (хроническое бактерионосительство) влечет за собой отстранение от работы в перечисленных выше учреждениях, согласно специальной инструкции, на все время бактерионосительства

То же, что и при брюшном тифе.

Изоляция больного прекращается после трехкратного отрицательного результата исследований испражнений на холерных вибрионов с двухдневным перерывом между исследованиями.

Первое исследование производится не ранее 6 дней после клинического выздоровления от холеры.

Примечание. При отсутствии в данном населенном пункте бактериологической лаборатории работники предприятий, упомянутых в п. 2 раздела I, должны посылаться за счет здравоохранения ближайшую бактериологическую лабораторию для производства заключительного контроля по п. «д»; до этого времени не допускаются к работе по своей специальности в течение 3/1а месяцев

То же, что и при брюшном тифе

Изоляция прекращается после двукратного отрицательного результата исследований на холерных вибрионов, но не ранее 6 дней со дня соприкосновения с больным.

В случае обнаружения среди контактировавших бактерионосителей, для них устанавливаются те же сроки изоляции, что и для больного.

То же, что и при брюшном тифе  
Госпитализация  
обязательна  
больного

2. Паратифи

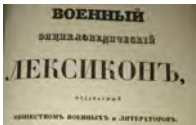
3. Холера

З  
а  
р  
а  
з  
н  
ы  
е  
б  
о  
л  
е  
з  
н  
и

В  
о  
з  
в  
р  
а  
щ  
е  
н  
и  
е

| Название болезни          | Раздел I<br>Продолжительность срока изоляции лиц, перенесших заразные заболевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Раздел II<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, бывших в соприкосновении с заразными больными до момента изоляции больного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Раздел III Продолжительность срока и формы разобщения лиц, находящихся в общении с заразными больными в течение всего периода болезни при оставлении больного на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Дизентерия бациллярная | 1. Изоляция больного прекращается после двукратного отрицательного исследования испражнений. Первое исследование производится после исчезновения клинических явлений, второе и последующее — с двух дневными промежутками. Для детей до 3 лет в случае наличия у них неоформленного стула в течение продолжительного времени изоляция прекращается после трехкратного отрицательного исследования.<br>В случае невозможности произвести бактериологическое исследование изоляция прекращается не ранее 7—8 дней после исчезновения клинических симптомов (оформленный стул и нормальная температура). | Разобщение не применяется. Всем лицам, окружающим больного, по установлении диагноза проводится обязательное фагирование, и за ними устанавливается медицинское наблюдение в течение 5 дней. Лица, обслуживающие предприятия и учреждения, перечисленные в разделе II «Брюшной тиф», п. 2, подвергаются обязательному однократному бактериологическому исследованию с установлением 5-дневного медицинского наблюдения. Обнаруженные бациллоносители не допускаются к работе до получения двукратного отрицательного результата бактериологического исследования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Госпитализация больного обязательна. При оставлении больного на дому (о разрешения эпидемиолога):<br>а) лица, проживающие в одной квартире с заболевшим, подлежат обязательному фагированию и медицинскому наблюдению в течение всего времени болезни и в течение 5 дней после выздоровления;<br>б) лица, ухаживающие за заболевшим, допускаются к работе после выздоровления больного, проведения фагирования, производства заключительной дезинфекции с установлением за ними после выздоровления больного медицинского наблюдения в течение 5 дней;<br>в) разобщению подлежат лица, обслуживающие перечисленные в разделе I «Брюшной тиф», п. 2 предприятия и учреждения, куда они допускаются только по выздоровлении больного, проведении фагирования, производстве заключительной дезинфекции и при соблюдении правил, указанных в разделе II «Брюшной тиф», п. 2 |
| 6. Возвратный тиф         | Реконвалесценты-бациллоносители после окончания изоляции подлежат медицинскому наблюдению, согласно специальной инструкции. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Госпитализация больного обязательна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Оспа натуральная       | 2. Работники предприятий и учреждений, поименованные в разделе I «Брюшной тиф», п. 2, допускаются к работе по своей специальности только после двукратного отрицательного бактериологического исследования с соблюдением всех правил, указанных для брюшного тифа.<br>Изоляция больного прекращается через 12 дней после появления температуры при условии                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Сыпной тиф                | тщательной санитарной обработкой его в больничном учреждении<br><br>Изоляция больного прекращается через 15 дней после последнего приступа при условии нормальной температуры в течение этого времени и тщательной санитарной обработки в больничном учреждении. Больной остается под медицинским наблюдением в течение 1 месяца.<br>Изоляция больного прекращается после полного отпадения корок, но не ранее 40 дней со дня заболевания                                                                                                                                                             | Разобщение прекращается после тщательной санитарной обработки и дезинсекции белья, одежды, постельных принадлежностей и помещений больного с установлением медицинского наблюдения, с термометрированием всех соприкасавшихся с больным в течение 25 дней и последующим эпидемиологическим надзором за очагом в течение 45 дней. То же, что при сыпном тифе<br><br>Разобщение прекращается после изоляции больного, производства дезинфекции и прививки оспы всем окружающим больного лицам (начиная с двухнедельного возраста). После этого устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней с момента прекращения контакта с заболевшим и производства заключительной дезинфекции. В случае наличия в окружении больного ни разу не вакцинированных лиц последние изолируются на дому в течение 14 дней с установлением за ними ежедневного медицинского наблюдения.<br><br>П р и м е ч а н и е . Прививки против оспы производятся немедленно после выявления оспенного больного или подозрительного на оспу заболевания | Госпитализация больного обязательна<br><br>Госпитализация больного обязательна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





| Название болезни        | Раздел I<br>Продолжительность срока изоляции лиц, перенесших заразные заболевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Раздел II<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, бывших в соприкосновении с заразными больными до момента изоляции больного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Раздел III<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, находящихся в общении с заразными больными в течение всего периода болезни при оставлении больного на дому                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оспа<br>ветряная        | Изоляция больного прекращается после отпадения корок.<br><br>Примечание. При появлении повторных заболеваний в детском учреждении заболевший допускается в данное детское учреждение по исчезновении острых явлений болезни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Для детей, перенесших болезнь, и взрослых разобщение не применяется. Для детей ясельного и дошкольного возраста и начала непременных болезней разобщение применяется в течение 21 дня школьного возраста и взрослых с момента контакта. При установлении точного времени контакта дети допускаются в детские учреждения в течение первых 10 дней инкубации и подлежат разобщению с 11-го по 21-й день инкубации. Для школьников разобщение не применяется.<br><br>Примечание. При появлении повторных заболеваний в детском учреждении разобщение не применяется и по отношению к детям, не перенесшим болезни                                                                                                                                                                                                                | Для детей ясельного и дошкольного возраста разобщение применяется в течение 21 дня от заболевания. Для детей школьного возраста и взрослых разобщение не применяется                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Корь                 | Изоляция больного прекращается через 5 дней от начала высыпания; при наличии осложнений (пневмонии)—не ранее 10 дней от начала высыпания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Для детей, перенесших болезнь, и взрослых разобщение не применяется. Для детей, не перенесших болезни, длительность разобщения от момента контакта с заболевшим корью для непривитых 21 день, для привитых—28 дней.<br><br>Примечание. В окраинных отдаленных районах, где не было кори в течение длительного периода, разобщение применяется ко всем возрастам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | При нахождении больного на дому сроки разобщения для детей, не болевших корью, удлиняются до 26 дней для непривитых и до 33 дней для привитых с учетом срока возможной инкубации от момента контакта в последний день острого периода кори                                                                                                                                                    |
| 10. Краснуха<br>коровая | Изоляция больного прекращается через 6 дней от начала высыпания.<br><br>Примечание. При появлении повторных заболеваний в детском учреждении заболевший допускается в данное учреждение после исчезновения острых явлений болезни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Разобщение не применяется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разобщение не применяется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Скарлатина          | Изоляция больного прекращается по истечении 40 дней от начала заболевания. В легких случаях, протекавших без осложнений, и при отсутствии каких-либо явлений со стороны слизистой зева и носоглотки допускается более ранняя выписка из лечебного учреждения, но не ранее 30 дней от начала заболевания.<br><br>Примечания. 1. Выздоравливающие дети по миновании острых явлений переводятся в отдельные палаты реконвалесцентов или в специальные учреждения для реконвалесцентов.<br>2. Для детей, переболевших скарлатиной, посещающих детские учреждения, а также для взрослых, обслуживающих детские учреждения, работников детских, хирургических и родильных отделений, работающих на молочных фермах, занятых сбором и торговлей молоком, устанавливается дополнительная изоляция на дому в течение 12 дней со дня выхода из больницы. | 1. Для детей до 12 лет, не перенесших скарлатины при отсутствии у них воспалительных явлений со стороны зева и носоглотки устанавливается разобщение на 12 дней с обязательным патронажным наблюдением.<br>2. Для лиц нижеследующих категорий устанавливается разобщение до производства заключительной дезинфекции при отсутствии у них воспалительных явлений со стороны зева и носоглотки с последующим медицинским наблюдением в течение 12 дней:<br>а) для всех лиц, проживающих в одной комнате с заболевшим;<br>б) для проживающих в одной квартире, с заболевшим:<br>1) детей, перенесших скарлатину;<br>2) детей, не перенесших скарлатины, в возрасте старше 12 лет,<br>3) взрослых, обслуживающих детские учреждения, детские хирургические и родильные отделения, детские библиотеки, детские универмаги, а также | Госпитализация обязательна. При оставлении больного на дому по разрешению эпидемиолога) разобщение применяется по отношению к ухаживающему персоналу в течение 52 дней с момента заболевания для всех групп, перечисленных в разделе II, п. 2, и 40 дней для остальным групп населения. При появлении среди контактировавших заболевания ангины разобщение применяется как в разделе II, п. 3 |

С  
К  
О  
Р  
О  
И  
О  
И  
Я

О  
О  
О

Ц

О  
И  
И  
У

| Название болезни                               | Раздел I<br>Продолжительность срока изоляции лиц, перенесших заразные заболевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Раздел II<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, бывших в соприкосновении с заразными больными до момента изоляции больного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Раздел III<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, находящихся в общении с заразными больными в течение всего периода болезни при оставлении больного на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скарлатинозная краснуха (4-я болезнь Филатова) | <p>" Для детей из закрытых детских учреждений 12-дневная дополнительная изоляция после 40 дней больничной изоляции допускается в изоляторе закрытого детского учреждения</p> <p>Изоляция больного в течение 21 дня. В случае появления вторичных признаков скарлатины изоляция продолжается согласно срокам изоляции при скарлатине</p> <p><b>Примечание.</b> Ввиду трудности дифференциального диагноза скарлатинозной краснухи от скарлатины, скарлатинозную краснуху следует считать заболеванием, подозрительным на скарлатину</p> <p>Изоляция больного прекращается по истечении 40 дней (с начала заболевания или 30 дней от начала судорожного кашля</p>                              | <p>для лиц, работающих на мелких фермах, занятых сбором молока и торгующих молоком.</p> <p>В случае появления ангины, подозрительных на скарлатину, в течение 12 дней разобщения или медицинского наблюдения срок разобщения для заболевших ангиной продолжается до 21 дня с начала заболевания для выявления могущих проявиться вторичных признаков скарлатины. В случае подтверждения диагноза скарлатины сроки разобщения устанавливаются, как при скарлатине</p> <p>Согласно срокам разобщения при скарлатине в случае подтверждения диагноза скарлатины или на 21 день в случае диагноза краснухи</p> <p>Для детей до 10 лет, не перенесших болезни, разобщение прекращается при отсутствии у них кашля по истечении 21 дня от момента последнего контакта с больным.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>Согласно срокам разобщения при скарлатине в случае подтверждения диагноза скарлатины или на 21 день в случае диагноза краснухи</p> <p>Для детей до 10 лет, не перенесших болезни, разобщение прекращается через 40 дней от начала заболевания или 30 дней от начала судорожного кашля. В отношении детей старше</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. Коклюш                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. Дифтерия                                   | <p>Изоляция больного прекращается после двукратного отрицательного исследования отделяемого зева и носоглотки, произведенного с двухдневными промежутками.</p> <p>1. При продолжающемся бактерионосительстве общий срок изоляции у переболевших дифтерией не должен превышать 60 дней со дня клинического выздоровления.</p> <p>2. Допускается более ранняя выписка из больницы этих лиц при отсутствии у них воспалительных явлений со стороны зева и носоглотки, но не ранее 30 дней со дня клинического выздоровления.</p> <p>3. Сокращение срока изоляции на 30 дней не распространяется на лиц, посещающих детские учреждения, живущих в общежитиях или в многонаселенных квартирах</p> | <p>Для детей старше 10 лет, а также взрослых, обслуживающих детские учреждения, разобщение не применяется, но за ними устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней</p> <p>Разобщение прекращается после изоляции больного, дезинфекции и однократного отрицательного бактериологического исследования, при отсутствии острых воспалительных явлений со стороны зева и носоглотки как для детей, так и для взрослых, обслуживающих детские учреждения и молочные предприятия.</p> <p>В случае обнаружения у этих лиц бактерионосительства разобщение для них прекращается только после двукратного отрицательного бактериологического исследования.</p> <p>При невозможности произвести исследование разобщение прекращается через 7 дней после изоляции больного при отсутствии острых явлений со стороны зева и носоглотки</p> <p><b>Примечание.</b> Бактерионосители — дети, а также и взрослые, вышеперечисленных категорий — подлежат разобщению до получения двукратного</p> | <p>10 лет и старше взрослых, обслуживающих детские учреждения, разобщение не применяется, но они остаются под медицинским наблюдением в течение 40 дней от начала заболевания</p> <p><b>Примечание.</b> Дети ясельного и дошкольного возраста могут быть допущены в детские учреждения при условии изоляции в самом учреждении путем выделения их в отдельные группы</p> <p>Госпитализация обязательна. В случае оставления больного на дому (с разрешения эпидемиолога) применяются все мероприятия, указанные в разделах I и II, т. е. разобщение прекращается после клинического выздоровления и получения двукратного отрицательного результата бактериологического исследования у больного, разобщение для ухаживающих за больным лиц прекращается после окончания срока изоляции больного и получения однократного отрицательного результата бактериологического исследования</p> |

| Название болезни                                     | Раздел I<br>Продолжительность срока изоляции лиц, перенесших заразные заболевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Раздел II<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, бывших в соприкосновении с заразными больными до момента изоляции больного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Раздел III<br>Продолжительность срока и формы разобщения лиц, находящихся в общении с заразными больными в течение всего периода болезни при оставлении больного на дому                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 а. Свинка                                          | Изоляция больного прекращается че <sup>ге</sup> ) 21 день от начала заболевания, но не ранее исчезновения клинических явлений! болезни. Для взрослых, не обслуживающих детские учреждения,— по исчезновении клинических явлений болезни.<br><br>Примечание. При появлении повторных заболеваний в детском учреждении заболевший допускается в данное детское учреждение по исчезновении острых явлений болезни                 | отрицательного результата бактериологического исследования, произведенного с промежутком в 2 дня. Однако общий срок изоляции не должен превышать 60 дней с начала установления бациллоносительства<br><br>Разобщение устанавливается в течение 21 дня от начала заболевания. Для детей, перенесших болезнь, а для детей старше 12 лет, а также взрослых разобщение не применяется<br>Дети, не бр <sup>ев</sup> вшие свинкой, при точном установлении времени контакта допускаются в детские учреждения в первые 10 дней инкубации, а с 11-го по 21-й день инкубации подлежат разобщению.<br><br>Примечание. При появлении повторных заболеваний в детском учреждении разобщение не применяется и по отношению и детям, не перенесшим болезни | Для детей, перенесших болезнь, для детей старше 12 лет, а также взрослых разобщение не применяется. Для детей до 12 лет, не болевших свинкой, устанавливается разобщение на 21 день от начала заболевания                                                                                                                                                                                                                             |
| • Цереброспинальный менингит                         | Изоляция больного прекращается после двукратного отрицательного результата исследования отделяемого носоглотки на менингококки<br>Первое контрольное исследование делается после исчез-                                                                                                                                                                                                                                        | Для детей и взрослых, обслуживающих детские учреждения а детские больницы, разобщение прекращается после двукратного отрицательного исследования отделяемого носоглотки. При невозможности про-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Госпитализация обязательна. При оставлении больного на дому (с разрешения эпидемиолога) разобщение для детей и взрослых, обслуживающих детские учреждения, прекращается после клинического выздоров-                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17. Эпидемический энцефалит                          | новения острых клинических явлений, но не ранее 21 дня от начала заболевания. При невозможности произвести бактериологическое исследование изоляция прекращается не ранее 30 дней от начала заболевания при отсутствии острых мозговых явлений, а при септической форме — при отсутствии септических явлений со стороны ножи, суставов и т. д.<br><br>Изоляция больного прекращается после исчезновения острых явлений болезни | известии бактериологическое исследование—через 7 дней после разобщения с больным<br><br>Разобщение не применяется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ления больного (раздел I) и после двукратного отрицательного результата бактериологического исследования отделяемого носоглотки у контактировавших с больным.<br>При невозможности произвести исследование разобщение прекращается через 7 дней по истечении срока изоляции больного<br><br>Госпитализация больного обязательна. При оставлении больного на дому (с разрешения эпидемиолога) разобщение для окружающих не применяется |
| 18. Эпидемический полиомиелит (болезнь Гейне-Медина) | Изоляция больного прекращается после исчезновения острых явлений болезни, но не ранее 14 дней от начала заболевания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Для детей, не перенесших болезни, и взрослых, работающих в детских учреждениях ясельного и дошкольного возраста, разобщение прекращается через 20 дней при отсутствии воспалительных явлений со стороны носоглотки и клинических явлений со стороны кишечника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Госпитализация больного обязательна<br>Госпитализация больного обязательна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. Сип ...                                          | Изоляция больного При острой форме на весь период болезни; при хронической форме— на все время наличия у больного незаживших ран. По выздоровлении больной находится под длительным (в течение нескольких лет) врачебным наблюдением                                                                                                                                                                                           | Разобщение не применяется, но устанавливается медицинское наблюдение в течение 15 дней после прекращения общения с больным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Госпитализация больного обязательна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. Чума                                             | При бубонной форме чумы изоляция больного прекращается не ранее чем через месяц после исчезновения клинических симптомов (обратного раз-                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Проводится индивидуальная изоляция. Изоляция прекращается через 9 дней после разобщения с больным при нормальной температуре (обяз-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

©

Ш  
на  
у  
ио  
р  
я  
а  
о  
и  
щ  
к  
о  
о  
к  
и  
к  
о  
в  
Е  
и

| Название болезни   | Раздел I<br>Продолжительность срока изоляции лиц, перенесших заразные заболевания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Раздел II<br>Продолжительность срока п<br>формы разобщения лиц, бывших в соприкосновении с заразными больными до момента изоляции больного                                                                                                                                                                                      | Раздел III Продолжительность срока и формы разобщения лиц, находящихся в общении с заразными больными в течение всего периода болезни при оставлении больного на дому                                                   | а<br>в<br>н<br>к<br>с<br>о                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Сибирская язва | <p>випп ил п рассасывания бубонп в или после заживления кожных язв, образовавшихся на месте вскрывшихся бубонов, карбункулов или пустул).</p> <p>При легочной форме и вторичной пневмонии — по получении отрицательных результатов при многократном исследовании мокроты на чумные палочки</p> <p>При кожной форме сибирской язвы ИЗОЛЯЦИЯ прекращается после отпадения струпуев, эпителизации и рубцевания язв: при септической, легочной я кишечной форме — после клинического выздоровления пдвукратного отрицательного результата бактериологических исследований, производимых с интервалами в 5 дней (в зависимости от формы болезни производится исследование крови, мокроты, испражнение и мочи)</p>                                                                                                             | <p>тельная термометрия два раза в день — утром и вечером). При применении сыворотки срок пазобщения удлинняется до 12 дней</p> <p>Разобщение не применяется. За лицами, соприкасавшимися с больным человеком или больным животным, устанавливается медицинское наблюдение в течение 8 дней после прекращения общения с ними</p> | <p>Госпитализация обязательна</p> <p>больного</p>                                                                                                                                                                       | " М<br>м<br>о<br>а<br>т                                                      |
| 22. Рожа           | <p>Изоляция больного прекращается после исчезновения клинических явлений</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Разобщение не применяется. Для лиц медицинского и ухаживающего персонала хирургических и родильных отделений, находящихся и общении с рожистым больным, устанавливается разобщение до изоляции больного и санитарной обработки контактировавших</p>                                                                          | <p>Разобщение не применяется. Для лиц медицинского и ухаживающего персонала хирургических и родильных отделений проводится разобщение до клинического выздоровления больного и последующей санитарной его обработки</p> |                                                                              |
| 23. Бруцеллез      | <p>Выписка больного производится после исчезновения острых клинических явлений. Переболевшие бруцеллезом допускаются к производству молочных продуктов только после двукратного бактериологического исследования крови и мочи с отрицательным результатом. Интервал между исследованием ;одженбытьнеменее7—10 дней. Бактериологическое исследование может производиться только в специальных лабораториях.</p> <p>При невозможности производства бактериологического исследования переболевшие могут быть допущены к производству молочных продуктов, не подвергающихся последующей термической обработке, через 2 месяца после окончания острых явлений. За такими работниками должно быть установлено тщательное медицинское наблюдение, а переболевшие должны быть проинструктированы о мерах личной профилактики</p> | <p>Разобщение не Применяется</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Разобщение не применяется</p>                                                                                                                                                                                        | о<br>о<br>с<br>ы<br>и<br>а<br>с<br><br>> ><br>о<br>и<br><br>о<br>и<br>е<br>м |



## ИСТОЧНИКИ И ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

| Название болезни                                   | Источник и заражения                                                            |      |                                               | Пути распространения |       |               |                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | люди                                                                            | люди | больные животные и птицы (мясо, шкура и т.п.) | внешняя среда        |       |               |                  |                                                                                                                                                   | членистоногие                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                 |      |                                               | воздух               | почва | питьевая вода | пищевые продукты | жилище, одежда и предметы домашнего обихода (мебель, посуда и игрушки)                                                                            |                                                                                                                                         |
| 1                                                  | 2                                                                               | 3    | 4                                             | 5                    | 6     | 7             | 8                | 9                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                      |
| Брюшной тиф . . .                                  | + с первых же дней заболевания                                                  | +    | 0                                             | 0                    | (+)   | +             | +                | + посуда, белье, отхожие места                                                                                                                    | + мухи                                                                                                                                  |
| Паратиф А и Б . .                                  | + с первых же дней заболевания                                                  | Н-   | (+) для паратифа Б                            | 0                    | (+)   | +             | +                | + посуда, белье, отхожие места                                                                                                                    | + мухи                                                                                                                                  |
| Пищевые отравления (токсикоинфекция) . . . . .     | 0                                                                               | 0    | + мясо больных животных                       | 0                    | 0     | 0             | +                | 0                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| Лизентерия багrippлярная . . . . .                 | 4-                                                                              | +    | 0                                             | 0                    | 0     | (+)           | +                | +                                                                                                                                                 | + мухи                                                                                                                                  |
| Холера . . . . .                                   | +                                                                               | +    | 0                                             | 0                    | 0     | +             | +                | +                                                                                                                                                 | + мухи                                                                                                                                  |
| Сыпной тиф . . . .                                 | + только при наличии вшей                                                       | 0    | +                                             | и                    | 0     | 0             | 0                | + только при наличии вшей, главным образом белье и одежды + наличие вшей, главным образом белье и одежды ; при клещевом тифе — при наличии клещей | + вши (заразительны через 5—6 дней после укуса вошью больного сыпным тифом)                                                             |
| Возвратный тиф . .                                 | + только при наличии вшей; при клещевом тифе—при наличии клещей                 | 0    | 0                                             | 0                    | 0     | 0             | 0                | +                                                                                                                                                 | + вши, при клещевом тифе — клещи                                                                                                        |
| Малярия . . . . .                                  |                                                                                 |      |                                               |                      | 0     | 0             | 0                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Москитная лихорадка (паппатачи) . . . . .          |                                                                                 |      |                                               |                      | 0     | 0             | 0                |                                                                                                                                                   | + самка комара анофелеса (заразительная через 1-7 недель после укуса комаром больного малярией в зависимости от окружающей температуры) |
| Скарлатина . . . . .                               |                                                                                 |      |                                               |                      | +     | 0             | 0                | (+) молоко                                                                                                                                        | + флеботомус (москиты)                                                                                                                  |
| Дифтерия . . . . .                                 |                                                                                 |      |                                               |                      |       | 0             | 0                |                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                       |
| Корь . . . . .                                     | + с первого дня prodromы до исчезновения сыпи + с первых же дней заболевания -г |      |                                               |                      | +     | 0             | 0                | (+) молока 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                       |
| Коклюш . . . . .                                   |                                                                                 | (+)  |                                               |                      | +     | 0             | 0                |                                                                                                                                                   | (+) (+)                                                                                                                                 |
| Ветряная оспа . . . .                              |                                                                                 |      |                                               |                      | 0     | 0             | 0                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Натуральная оспа . . . .                           | + "                                                                             |      |                                               |                      | +     | 0             | и                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Эпидемический цереброспинальный менингит . . . . . |                                                                                 |      |                                               |                      | +     | 0             | 0                | -г- белье (особенно носовые платки, общие полотенца)                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Эпидемический анцефалит: весенне-летний . . . . .  |                                                                                 |      |                                               |                      | 0     | 0             | 0                |                                                                                                                                                   | 0 (+)                                                                                                                                   |
| японский . . . . .                                 |                                                                                 |      | -г грызуны                                    |                      | 0     | 0             | 0                |                                                                                                                                                   | f иксодовые клещи                                                                                                                       |
| типа Экономо . . . . .                             |                                                                                 |      |                                               |                      | +     | 0             | 0                |                                                                                                                                                   | + комары                                                                                                                                |
| Подпоясанный . . . . .                             |                                                                                 |      |                                               |                      | +     | 0             | (+)              |                                                                                                                                                   | и 0                                                                                                                                     |
| Эпидемический наротит . . . . .                    |                                                                                 |      |                                               |                      | (+)   | 0             | 0                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |

| Название болезни | Источники заражения |                      |                                                                      | Пути распространения                  |        |                 |                                                                                                                |                                                                        |                                      |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | больные люди        | да-но-сители ин-фек- | больные жи-вотные и продукты (мясо, шкуры и т. д.)                   | внешняя среда                         |        |                 |                                                                                                                |                                                                        | членистоногие                        |
|                  |                     |                      |                                                                      | воз-дух                               | поч-ва | пи-ть-е-вая во- | пищевые продукты                                                                                               | жилище, одежда и предметы домашнего обихода (мебель, посуда и игрушки) |                                      |
| 1                | 2                   | 3                    | 4                                                                    | 5                                     | 6      | 7               | 8                                                                                                              | 9                                                                      | 10                                   |
| Грипп            | +                   | (+?)                 | 0                                                                    | (+)                                   | 0      | 0               | 0                                                                                                              | (+), особенно носовые платки и общее полотенце                         | 0                                    |
| Туляремия        | +                   | 0                    | + грызуны, верблюды                                                  | +при легочной чуме 0                  | 0      | 0               | (+) мясо чумных грызунов и верблюдов                                                                           | +                                                                      | + блохи                              |
|                  | 0                   | 0                    | + полевые грызуны, кролики, водяные крысы, зайцы, кошки и т. д.      |                                       | 0      | +               | (+)мясо больных кроликов и зайцев. Зерно, загрязненное выделениями больных грызунов, и другие пищевые продукты | 0                                                                      | + блохи, клещи, комары, муха-жигалка |
| Сибирская язва   | (?)                 | 0                    | +                                                                    | (+)в лаборатор- (+)при легочной форме | (+)    | (+)             | +                                                                                                              | 0                                                                      | 0                                    |
|                  | (+)                 | 0                    | Ч- главным образом травоядные, особенно их туши, шкуры, шерсть и пр. |                                       | (+)    | (+)             | (+)                                                                                                            | + тулупы, меховые головные уборы, валенки, сапоги, щетки, и др.        | + мухи (особенно жигалка)            |
| Ящур             | 0 0                 |                      |                                                                      | (+)                                   |        |                 | (+) МОЛОКО больных коров                                                                                       | кисточки для бритья и т. д.                                            | 0                                    |
| Бешенство        | Г(+)                |                      | + домашние и хищные животные, особенно собаки, волки, лисы           | 0                                     |        |                 | 0                                                                                                              |                                                                        |                                      |
| Сап. Столбняк    |                     |                      | + -2 травоядные                                                      |                                       | 0 0    | 0 0             |                                                                                                                |                                                                        |                                      |
| Лептоспирозы     |                     |                      | грызуны                                                              |                                       | +      | +               |                                                                                                                | (+) вещи, загрязненные землей                                          |                                      |
| Газовая гангрена |                     |                      | 0                                                                    |                                       | и      | 0               | (+) 0                                                                                                          | /+ вещи, загрязненные землей                                           |                                      |

Условные обозначения: 4- наиболее часто или всегда; (+) редко; ? сомнительная возможность; 0 никогда или очень редко.

## ВОЗБУДИТЕЛИ ВАЖНЕЙШИХ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

| Название болезни                                                                                                                                                              | Название возбудителя                                                                                                                          | Жизнеспособность возбудителя во внешней среде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Брюшной тиф                                                                                                                                                                   | Бактерия брюшного тифа                                                                                                                        | В текучей воде выживает до 5—10 дней, в стоячей воде — до 4 недель, в иле прудов и колодцев — до нескольких месяцев (в зависимости от температуры); во льду — до нескольких месяцев, в выгребных ямах и почве — свыше одного месяца, в сыром молоке на холоду — до 35 дней, на поверхности овощей и фруктов — от 5 до 10 дней; в различных пищевых продуктах — масле, сыре, мясе — от 1 до 3 месяцев; на белье, платье, посуде — до 2 недель; на шерстяной ткани — до 30 дней<br>То же, что и бактерия брюшного тифа<br>То же, что и бактерия брюшного тифа<br>В организме больных животных, в мясе и мясных продуктах в течение длительного времени<br>Во влажной почве сохраняются несколько месяцев, могут перезимовать под снегом; на грязном белье — от 1 до 2 недель; на хлебе, овощах, фруктах — до 2 недель; в молочных продуктах — от 8 до 10 дней; в кишечнике комнатной мухи — более 10 дней<br>В испражнениях выживает 2—3 дня; на грязном белье — 12 дней; в глубоких слоях почвы — до 2 месяцев, в воде — от 8 до 14 дней; во льду — несколько месяцев; в сыре и молоке — от 1 до 6 дней, в стерилизованном молоке (про последующем загрязнении) — до 10 дней; в масле — до 30 дней; на овощах, ягодах и фруктах — от 10 до 12 дней; в холерных трупах — от 3 до 4 недель<br>В организме зараженных вшей сохраняются до конца жизни вши, т. е. в течение 24—30 дней; в кале вшей — до нескольких месяцев (?); в крови, взятой от больного, при сохранении на холоду — от нескольких часов до 7 дней<br>В крови, взятой от больного, сохраняется от нескольких часов до нескольких дней (дольше всего — при комнатной температуре), но это не имеет эпидемиологического значения, в организме зараженных вшей — от 12 до 25 дней<br>В организме зараженного клеща ( <i>C. nitidus</i> ) и зараженных грызунов (песчанки) — длительное время | М<br>С<br>О<br>£<br>О<br>В |
| Паратиф А<br>Паратиф Б<br>Пищевые отравления (токсикоинфекции)<br>Дизентерия бациллярная                                                                                      | Бактерия паратифа А<br>Бактерия паратифа Б<br>Группа возбудителей пищевых токсикоинфекций<br>Различные разновидности возбудителя дизентерии   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Холера                                                                                                                                                                        | Холерный вибрион                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Сыпной тиф                                                                                                                                                                    | Риккетсии Прованса                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Возвратный тиф вшив                                                                                                                                                           | Спирохета                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Возвратный тиф (клещевой)                                                                                                                                                     | Спирохета возвратного клещевого тифа                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Малярия                                                                                                                                                                       | Плазмодий малярии (четыре типа)<br>Плазмодиум вивакс<br>Плазмодиум малярии<br>Плазмодиум фальципарум<br>Плазмодиум овале<br>Фильтрующий вирус | В крови, взятой от больного, на холоду сохраняется несколько дней; в организме комара анофелеса — в течение всей его жизни (в летне-осенний период — от 2 до 3 месяцев)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Москитная лихорадка (паппатачи)<br>Скарлатина                                                                                                                                 | Возбудитель окончательно не установлен, одни авторы считают возбудителем скарлатины гемолитический стрептококк, другие — фильтрующий вирус    | Сохраняется в организме москита (флеботомус)<br>Гемолитический стрептококк в обычных условиях быстро погибает; в высушенном виде сохраняется до полугода; о сохранности фильтрующего вируса при скарлатине данных не имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | С                          |
| Дифтерия                                                                                                                                                                      | Бактерия дифтерии                                                                                                                             | В засохших пленках из зева при отсутствии света сохраняет свою жизнеспособность до 3 месяцев; на солнце погибает через несколько часов; в молоке и воде может жить до 3 недель<br>Быстро погибает при высушивании и под влиянием света<br>То же<br>» »<br>В высушенном состоянии (в пыли, на вещах, на одежде), а также в замороженном виде оспенный вирус сохраняется длительное время<br>Быстро погибает на свету при достаточной аэрации и при высушивании<br>В организме иксодовых клещей сохраняется длительное время<br>Сохраняется в организме комаров. Длительность сохранения изучается<br>Сохраняется в каплях слюны, выделяемых Сальными при кашле и чихании, до высыхания<br>Быстро погибает при высушивании<br>В гною и подсохшей мокроте живет несколько месяцев, на одежде и белье — месяц, в организме блох — до 12 месяцев и больше; в чумных трупах — летом до 7—10 дней; зимой — до 5 месяцев (при низких температурах почвы — до 1/2 лет)<br>В высушенных цистах гризунов сохраняется до 2 месяцев, в зерне и фуражном жмыхе — до 3 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                          |
| Корь<br>Коклюш<br>Ветряная оспа<br>Натуральная оспа                                                                                                                           | Фильтрующий вирус<br>Бактерия<br>Фильтрующий вирус<br>Фильтрующий вирус (тельца Пашена)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Эпидемический цереброспинальный менингит<br>Клещевой (весенне-летний) энцефалит<br>Осепный (японский) энцефалит<br>Оспенный паротит (заушница)<br>Грипп<br>Эпидемический Чума | Менингококк<br>Фильтрующий вирус<br>То же<br>Бактерия чумы                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «§<br>а<br>О<br>и<br>§     |
| Туляремия                                                                                                                                                                     | Бактерия туляремии                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |



**ВОЗБУДИТЕЛИ ВАЖНЕЙШИХ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ  
ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ**

*Добавление VI*

| Название болезни                                                                                 | Название возбудителя                                                                                                                        | Жизнеспособность возбудителя во внешней среде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брюшной тиф                                                                                      | Бактерия брюшно-о тифа                                                                                                                      | В текучей воде выживает до 5—10 дней, в стоячей воде — до 4 недель, в иле прудов и колодезь — до нескольких месяцев (в зависимости от температуры); во льду — до нескольких месяцев, в выгребных ямах и ледяном сывце — до одного месяца, в сыром молоке на холоду — до 35 дней, на поверхности овощей и фруктов — от 5 до 10 дней; в различных пищевых продуктах — масле, сыре, мясе — от 1 до 3 месяцев, на белье, платье, посуде — до 2 недель; на шерстяной ткани — до 50 дней |
| Паратиф А<br>Паратиф Б<br>Паратифы<br>Паратифы<br>(токсикоинфекции)<br>Дизентерия<br>Бациллярная | Бактерия паратифа А<br>Бактерия паратифа Б<br>Группа возбудителей шигеллы токсикоинфекций<br>Различные разновидности возбудителя дизентерии | То же, что и бактерия брюшного тифа<br>То же, что и бактерия брюшного тифа<br>В организме больных животных, в мясе и мясных продуктах в течение длительного времени<br>Во влажной почве сохраняются несколько месяцев, могут перезимовать под снегом; на грядном белье — от 1 до 2 недель, на хлебе, овощах, фруктах — до 2 недель; в молочных продуктах — от 8 до 10 дней; в кизеичнике комнатной мухи — более 10 дней                                                            |
| Холера                                                                                           | Холерный вибрион                                                                                                                            | В испражнениях выживает 2—3 дня; на грядном белье — 12 дней; в глущих слоях почвы — до 2 месяцев, в воде — от 8 до 14 дней; во льду — несколько месяцев; в сыре и молоке — от 1 до 6 дней, в стерилизованном молоке (при последующем загрязнении) — до 10 дней; в масле — до 30 дней; на овощах, ягодах и фруктах — от 10 до 12 дней; в холерных трупях — от 3 до 4 недель                                                                                                         |
| Сыпной тиф                                                                                       | Риккетсия Провансана                                                                                                                        | В организме зараженныхвшей сохраняются до конца жизни виш. т. е. в течение 24—30 дней; в кале вишей — до нескольких месяцев (?); в крови, взятой от больного, при сохранении на холоду — от нескольких часов до 7 дней                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Возвратный тиф<br>выш                                                                            | Спирохета                                                                                                                                   | В крови, взятой от больного, сохраняется от нескольких часов до нескольких дней (полное всего — при комнатной температуре), но это не имеет эпидемиологического значения, в организме зараженныхвшей — от 12 до 25 дней                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Возвратный тиф<br>(клевочевой)                                                                   | Спирохета возвратного<br>клевочевой тифа                                                                                                    | В организме зараженного человека (Prothothogus) и зараженных грызунов (песчанки) — длительное время                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малярия                                                                                                                                                                   | Плазмодий малярии (четыре типа)<br>Плазмодий vivax<br>Плазмодий малярии<br>Плазмодий фалсипарум<br>Плазмодий овале<br>Фильтрующийся вирус<br>Возбудитель окончательного не установлен, один авторы считают возбудителем скрания гемолитический стрептококк, другие — фильтрующийся вирус<br>Бактерия дифтерии | В крови, взятой от больного, на холоду сохраняется несколько дней; в организме комара анофелеса — в течение всей его жизни (в летне-осенний период — от 2 до 3 месяцев)<br>Сохраняется в организме москита (флеботомус)<br>Гемолитический стрептококк в обычных условиях быстро погибает; в высушенном виде сохраняется до полутора; о сохранности фильтрующегося вируса при скрании данных не имеется<br>В засохших пленках из зева при отсутствии света сохраняет свою жизнеспособность до 3 месяцев; на солнце погибает через несколько часов; в молоке и воде может жить до 3 недель<br>Быстро погибает при высушивании и под влиянием света<br>То же<br>В высушенном состоянии (в пыли, на вещах, на одежде), а также в замороженном виде оспенный вирус сохраняется длительное время<br>Быстро погибает на свету при достаточной аэрации и при высушивании<br>В организме насекомых клещей сохраняется длительное время<br>Сохраняется в организме комаров. Длительность сохранения неизвестна<br>Сохраняется в напках слюны, выделяемых больными при кашле и чихании, до высыхания<br>Быстро погибает при высушивании<br>В гною и подсохшей мокроте живет несколько месяцев, на одежде и белье — месяц, в организме блох — до 12 месяцев и больше; в чумных трупях — летом до 7—10 дней; зимой — до 5 месяцев (при низких температурах почвы — до 1 1/2 лет)<br>В высушенных шкурах грызунов сохраняется до 2 месяцев, в зерне и фураж. зар. ж. инх. выделениями тулярийных грызунов, — несколько недель; в воде — до 3 месяцев |
| Корь<br>Коллаш<br>Ветряная оспа<br>Натуральная оспа                                                                                                                       | Фильтрующийся вирус<br>Бактерия<br>Фильтрующийся вирус<br>Фильтрующийся вирус (тельца Пашена)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Эпидемический персоброт-спинальный менингит<br>Клевочевой (весенне-летний) энцефалит<br>Осенний (июньский) энцефалит<br>Эпидемический паротит (заушница)<br>Грипп<br>Чума | Менингококк<br>Фильтрующийся вирус<br>То же<br>Бактерия чумы                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тулярия                                                                                                                                                                   | Бактерия туляремии                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Г Л А В А III

#### НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

##### АРАХНОИДИТ». ВОСПАЛЕНИЕ ПАУТИННОЙ ОБОЛОЧКИ МОЗГА (ARACHNOIDITIS).

Ограниченное воспаление оболочек мозга и скопление спинномозговой жидкости в спайках паутинной оболочки головного или спинного мозга. Возникает в результате общих инфекций, травмы головного или спинного мозга, вследствие перенесенного менингита, кровоизлияния под оболочки.

**Симптомы и течение.** Начинается высокой температурой. Рвота, мешшгеальные симптомы, судороги, параличи конечностей, сонливость. Все симптомы зависят от локализации процесса. В спинномозговой жидкости увеличено количество белка. Течение вялое. Отмечаются периодические улучшения.

**Распознавание** основывается на анамнезе и течении болезни. Дифференцировать с опухолью головного и спинного мозга.

**Лечение.** В остром периоде, как при инфекционном

забо-  
левании;  
в  
хрониче-  
ских  
стадиях  
—

йодисты  
е.препар  
аты,  
тепловы  
е  
процеду  
ры. При  
повыше  
нии  
внутрич  
ерепного  
давления  
—

внутри-  
мышечн  
ое  
введение  
5 мл 5%  
раствора  
сернокис  
лой  
магнези  
и (15—  
20  
инъекци  
й через  
день).  
Внутрив  
енно  
йодисты  
й иатрий  
(10%  
раствор)  
по 10 мл  
через  
день  
(8—10  
вливани  
й). При  
спинно-  
мозговы  
х  
арахно  
дитах  
люмбаль  
ные  
пункции  
или  
хирурги  
ческое  
вмешате  
льство.

R

p. Sol. Kalii jodati 8% 200,0

DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Pol. Magnesi sulfuric! 5% 5,0 Sterilis in  
amp. D. t. d. N. 10 S. Для  
внутримышечного введения

**АРТЕРИОСКЛЕРОЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ARTERIOSES XEROSIS CEREBRI).** Развивается преимущественно у пожилых людей после 40—50 лет.

**Симптомы и течение.** Головные боли, головокружение, шум в ушах, бессонница, ослабление памяти и работоспособности, неустойчивое настроение, слезливость, дрожание рук и языка! вялая реакция зрачков на свет. Течение хроническое, прогрессирующее. При тяжелых формах наступает инсульт--(см.).

**Распознавание.** Дифференцировать гипертоническую болезнь (см.).

**Лечение.** Регулярный режим работы и отдыха. Не курить, ограничение жидкости п острой пищи. Молочно-овощная диета.

14 Мед. справочник

Регулярное опорожнение кишечника. Длительное пребывание на воздухе. Внутрь йодистые препараты.

Rp. Saiodini 0,5 D. t. d. N. 18 S. По 1 таблетке 3 раза в день через час после еды

**БЕССОННИЦА (INSOMNIA).** Признак функциональных и органических заболеваний нервной системы, встречается также при инфекционных и соматических заболеваниях. У молодых людей после переутомления — при гипертонии, в пожилом возрасте вследствие атеросклероза головного мозга. Упорное нарушение сна, изменение его ритма, головные боли, головокружение должны наводить на мысль о возможности энцефалита (см.).

**Распознавание** основывается на тщательно собранном анамнезе и клинических наблюдениях.

**Лечение.** При бессоннице, сопровождающей внутренние или инфекционные болезни, необходимо лечить основное заболевание. Хороший эффект при лечении бессонницы, связанной с переутомлением, дает регулирование умственной работы, ограничение курения. При атеросклерозе — йодистые препараты, диуретин (по 0,5 три раза в день), прогулки, ножные горячие ванны перед сном, влажные укутывания, общие ванны с хвойным экстрактом. Хорошо действуют небольшие дозы брома, влияющие на тормозной процесс коры головного мозга (2% бромистый кальций). В случаях бессонницы, связанной с болевыми ощущениями, — пирамидон, фенацетин, хорошо в комбинации с люминалом.

Rp. Pyramidoni 0,3 Luminali 0,05 M. f. pulv. D. t. d. N. 12 • S. По 1 порошку перед сном

Rp. Luminal] 0,1  
I), t. d. N. 6  
S. По 1 порошку перед сном

Rp. Pyramidoni 0,5  
Luminali 0,1  
M. G. pulv. D. t. d. N. 10 S.  
По 2 порошка 2 раза в день

**БОЛЕЗНЬ ГЕЙНЕ-МЕДИНА** см. *Полиомиелит острый!*

**ВОДЯНКА ГОЛОВНОГО МОЗГА** см. *Гидроцефалия.*

**ГИДРОЦЕФАЛИЯ (HYDROCEPHALUS). ВОДЯНКА ГОЛОВНОГО МОЗГА.** Заболевание связано с чрезмерным накоплением спинномозговой жидкости в оболочках и полостях желудочков мозга, вследствие чего последние растягиваются и сдавливают вещество мозга. Чаще всего встречается в детском возрасте в результате перенесенного менингита; может быть вторичным при опухолях мозга и врожденным.

**Симптомы и течение.** Большие размеры черепа, увеличение родничков, расхождение черепных швов, расширение вен на голове, головные боли, застойные явления на дне глаза.

Эпилептические припадки, параличи, отсталость умственного развития, изменения психики, нарушение обмена веществ.

**Лечение.** При подозрении на сифилис (или в случаях врожденной водянки) — курс специфического лечения. В остальных случаях с целью рассасывания — йодистые препараты. Дегидратационная терапия: внутривенные вливания 40% раствора глюкозы (30—50 мл), 5% раствор сернокислой магнезии внутримышечно (5—10 мл), периодическое выпускание спинномозговой жидкости. Хирургическое лечение.

**ГОЛОВНАЯ БОЛЬ (CEPHALALGIA).** Причины весьма разнообразны: мозговые опухоли и абсцессы, сосудистые заболевания головного мозга, заболевания мозговых оболочек, инфекционные заболевания, отравления, малокровие, переутомление, нарушение зрения, заболевания придаточных полостей носа и др.

**Симптомы и течение.** Волны обычно наступают приступами. По характеру они могут быть тупые, давящие, стягивающие, острые, режущие, стреляющие. Часто сопровождаются тошнотой и рвотой. Интенсивность болей зависит от локализации и причин, которые их вызывают. Головные боли, связанные с повышением внутричерепного давления, резко усиливаются при кашле, чихании, сморкании, физическом напряжении в потугах. При малокровии при переутомлении боли тупые, локализируются в области лба, темени, висков; течение длительное, рвоты обычно не бывает. При мигрени (см.) головные боли своеобразны.

**Распознавание.** Тщательное выявление причин заболевания. Во всех случаях головных болей — исследовать дно глаза.

**Лечение.** Лечить основное заболевание. При повышении внутричерепного давления — внутримышечно 5—10 мл 5% сернокислой магнезии (10—15 инъекций). Внутрь пирамидон, фенацетин, кофеин.

Rp. Pyramidoni  
' Phenacetini aa 0,2 5 Coffeini natrio-benzoici  
0,1 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку  
при головной боли

**ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ (VERTIGO).** Симптом малокровия, переутомления, спазма мозговых сосудов, сотрясения мозга, поражения мозжечка, энцефалита, меньерового синдрома, заболевания внутреннего уха.

**Распознавание** основано на выявлении причины «заболевания. При меньеровом синдроме головокружение наступает приступами, сопровождающимися шумом в ушах, нарушениями равновесия, появлением нистагма, рвотой и глухотой. Оно может быть более или менее постоянным (малокровие, переутомление, энцефалит с поражением мозжечка), появляться при «переменах положения головы, вставании (поражение мозжечка, вестибулярного аппарата).

**Лечение.** При малокровии и переутомлении — общеукрепляющее лечение и отдых. При приступе меньеровой болезни — полный покой, лед на голову, тепло к ногам, инъекции атропина



(1 мл раствора 1 : 1 000). В периоды между приступами внутрь бромиды, люминал, кальций. При гипертонии — кропопускаие (200—300 мл) или пиявки, горчичники на сосцевидный отросток.

Rp. Sol. Calcii eblorati 10% 200,0

S. По 1 столовой ложке 3 раза в день Rp.

Natrii bromati\_

Kalii bromati aa 3,0

T-rae Valerianae 2,0

Aq. destill. 200,0

MDS. По 1 полосой ложке 3 раза в день

**ЗАЙКАНИЕ (BALBUTIES).** Расстройство речи наступает при испуге, страхе, травме, вследствие подражания, в результате истощения нервной системы после различных заболеваний. Особенно часто встречается как невроз в детском возрасте. При неврозах, согласно учению Павлова, возникает диссоциация деятельности коры головного мозга, а при заикании, повидимому, особенно страдает вторая сигнальная система как наиболее новая в эволюционно-циопном отношении (см. *Неврозы*).

**Симптомы заикания** проявляются разнообразно. Часто наблюдается наклонность к повторению первых звуков и слогов (клоническая форма) или же длительные остановки и нажим па первых звуках (топическая форма). Речь сопровождается поверхностным дыханием и быстрым выдыханием; часто речи сопутствуют непроизвольные движения в мыгапах лица, языка и конечностей.

**Лечение.** Общеукрепляющее: закаливание, сон па воздухе, влажные обтирания, гимнастика, психотерапия, создание спокойной обстановки и правильного режима дня. Обучение у логопеда. Приучать больных к медленной, плавной речи с глубоким вдохом и продолжительным выдохом; помогать больному подсказом слов, представляющих затруднение. Внутрь — препараты кальция, небольшие дозы брома и кофеина, глицерофосфаты, витамины.

Rp. Calcii bromati 3,0 Aq. destill. 200,0 MDS. По 1 столовой ложке 2 раза в день

**ИКОТА (SINGULTUS).** Клонические судороги диафрагмы, сопровождающиеся непроизвольными выдыхательными движениями. Протекает в виде приступов. Возникает как реакция после психических травм, при органических заболеваниях нервной системы (менингит, энцефалит), при заболеваниях внутренних органов (перитонит, непроходимость кишечника).

**Лечение.** В зависимости от основного заболевания. Внутрь люминал, хлороформ по 3—5 капель несколько раз в день, бромиды.

Rp. Luminali 0,1 D.

t. d. N. 6

S. По 1 порошку 2 раза в день

**ИНСУЛЬТ. МОЗГОВОЙ УДАР (APROPLEXIA CEREBRI).**

Может наступить вследствие кровоизлияния в головной мозг; при тромбозе мозговых сосудов (артериосклероз головного мозга,

сифилитический эндартериит), эмболии (при пороке сердца, эндокардите, аневризме аорты) и гипертонии.

**Симптомы и течение.** Мозговой инсульт при кровоизлияниях наступает внезапно, часто в связи с душевными переживаниями или тяжелым физическим напряжением; больной теряет сознание, лицо становится багровым, дыхание хрипящим, пульс замедляется и напрягается. При тромбозе развитие инсульта идет медленнее, и его наступлению могут предшествовать головные боли и головокружения; лицо становится бледным, пульс слабым, аритмичным. Эмболия наступает внезапно, без каких-либо предвестников; потеря сознания кратковременная. Часто во время инсульта можно отметить асимметрию (неправильность формы) лица, паралич руки и ноги, неравномерность рефлексов, рефлекс Вабинского, отведение глазных яблок и головы в сторону. Гипертонический инсульт наступает при значительном колебании гипертонических явлений. Гипертоническому инсульту обычно предшествует целая серия кризов, выражающихся в приступообразных головных болях, головокружениях, рвоте, бессоннице. Гипертонический инсульт часто протекает без потери сознания, но с большей или меньшей степенью оглушенности и спутанности. Развиваются параличи и нарушения чувствительности, чаще всего в форме гемиплегии. В момент инсульта опасность для жизни тем больше, чем обширнее кровоизлияние, чем дольше и глубже коматозное состояние. При эмболии прогноз для жизни благоприятнее, но в отношении параличей неблагоприятен: больной может научиться ходить с трудом и неполноценно владеть рукой; речь восстанавливается плохо.

**Распознавание** основывается на внезапном развитии мозговых симптомов. Необходимо иметь в виду возможность пищевой интоксикации, отравления, диабетическую кому (она сопровождается мышечной атонией и запахом ацетона изо рта), эклампсию (у беременных или у детей при высокой температуре), уремию (отмечается запах разлагающейся мочи).

**Лечение.** Абсолютный покой в постели с умеренно приподнятой головой. Холод на голову, тепло к ногам, пиявки за уши . (но 5—4 с каждой стороны), кропопускание (300—500 мл), очистительная клизма. Перевозка в больницу в остром периоде заболевания противопоказана. Особое внимание уделяют уходу: необходимо следить за сердцем и легкими, обтирать тело камфорным спиртом или водкой, пвпорачивать с бока па бок во избежание пролежней (очень осторожно). При задержке мочи — катетеризация; при запорах в остром состоянии — клизмы, затем легкие послабляющие средства (лакричный порошок). Дней через 10 после начала заболевания можно назначать йодистую терапию, лучше всего в виде раствора йодистого калия или натрия и диуретин; при беспокойстве — бромиды, люминал. В случаях сифилитического происхождения — специфическое лечение. Воздержание от избыточного питания, спиртных напитков и курения. По истечении 7—10 дней от начала заболевания — постепенное лечение массажем, активной и пассивной гимнастикой (начиная с 3—5 минут, избегая утомления). Через 1—2 месяца после острого периода показаны теплые ванны; через год — курортное лечение (Пятигорск, Сочи, Мацеста и др.).

- Rp. Diuntiiii 0,5  
Luminali 0,05  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12  
S. По 1 порошку 2 раза в день
- Rp. Natrii jodati 8,0 Aq. deetilt. 200,0 MDS.  
По 3 столовых ложки в день
- Rp. Inf. rad. Valerianae 6,0 : 200,0 Natrii bromati fi,0 MDS.  
По одной столовой ложке 3 раза в день

**ИШИАС. НЕВРИТ ИЛИ НЕВРАЛГИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА (ISCHIAS).** Наступает в результате инфекции или интоксикации часто при одновременном охлаждении.

**Симптомы и течение.** Постоянные или приступообразные боли, распространяющиеся на задней поверхности ягодицы, бедра и голени и усиливающиеся при малейшем сотрясении, кашле, чихании. Особенно резко выступают боли при надавливании на нерв, при одновременном растяжении нижней конечности в тазобедренном и коленном суставе (симптом Ласега). На больной конечности иногда отсутствует ахиллов рефлекс. Ишиас обычно начинается остро, длится 2—4 недели, имеет склонность к повторениям.

**Распознавание.** Нужно отличать боли в ноге, связанные с артритами, воспалительными явлениями в области малого таза, костными заболеваниями позвоночника, опухолями спинного мозга и др. Для первичного ишиаса характерно острое начало, односторонность процесса и отсутствие прогрессирования.

**Лечение.** Покой, постельное содержание, растирание летучими мазями, тепло (синий свет, грелки, бутылки с горячей водой, нагретый песок). Внутрь салициловые препараты, пирамидон (по 0,5 три раза в день), фенацетин, инъекция витамину В<sub>1</sub> (10—15 инъекций по 1—2 мл 0,05% раствора внутримышечно, по одной инъекции ежедневно). Внутривенное введение 0,25% раствора новокаина по ходу седалищного нерва. В подостром периоде — диатермия, кварц, легкий массаж, гальванизация с иодом. В затянувшихся, хронических случаях — курортное лечение: Саки, Одесса, Евпатория, Пятигорск, Мацеста, Старая Русса и др.

- Rp. Chloroformii  
01. Hyoscyami aa 10,0  
DS. Наружное для растирания

- Rp. Natrii salicylicii 0,5 D. t. d. N. 20 S. По  
1 порошку 4 раза в день

**КАУЗАЛГИЯ (CAUSALGIA).** Наблюдается особенно часто при травматических невритах военного времени, иногда при инфекционных поражениях периферического нерва.

**Симптомы и течение.** Жгучая боль по ходу поражения нервов, сухость кожи. Малейшее дотрагивание резко усиливает боли.

**Распознавание.** На основе анамнеза. Отличается от других сходных болевых синдромов остротой и длительностью течения.

**Лечение.** Иссечение невromы соответствующего нерва. Болеутоляющие: пирамидон, бромиды. Новокаиновая блокада по Вишневскому. Инъекции витамина I<sup>h</sup> (см. *Ишиас*). Физиотерапия: нонофорез с антипирином, продольная гальванизация позвоночника. Наложение вазелиновой повязки на больную конечность. Избегать инъекций морфина. Лечение сном.

#### **ЛИЦЕВОГО НЕЕВА ПАРАЛИЧ (PARALYSIS N. FACIALIS).**

Наступает в результате заболевания внутреннего уха, базиллярного менингита, опухоли мозга, ревматизма, как осложнение может входить в картину посттриппозного энцефалита. В детском возрасте паралич лицевого нерва встречается при болезни Гейне-Медина и в случаях родовой травмы.

**Симптомы и течение.** Начало острое. Односторонняя сглаженность на больной стороне лобной и носогубной складки, рот перетянут в здоровую сторону, веки раскрыты шире, чем на здоровой стороне, слезотечение. Болей нет.

**Распознавание.** Необходимо исключить поражение пахyderмных связей лицевого нерва (от коры мозга до ядра нерва — центральный паралич); в этих случаях парализуется не вся половина лица, а лишь нижняя его часть; больной в состоянии закрывать глаз и морщить лоб на больной стороне. Обязательно обследование уха.

**Лечение.** Лечение основного заболевания. В остром периоде, — уротропин внутрь (по 0,5 три раза в день) или внутривенно; внутривенные вливания глюкозы, инъекции витамина В<sub>1</sub> (см. *Ишиас*), внутрь — дибазол, местно — тепло (синий свет, грелки, парафин, диатермия). В затянувшихся случаях (дней через 12—15) — массаж лица и гальванизация. В случаях сифилитического происхождения — специфическое лечение.

- Rp. Sol. Urotropini 40% 5,0  
Sterilis! In amp. D. t. d. N. 6 S. По 5 мл  
внутривенно ежедневно Всего 12—15  
вливаний

- Rp. Sol. Glucodi 40% 10,0  
Sterilis! In amp. D. t. d. N. 10  
S. По 10 мл внутривенно ежедневно  
Всего 12—15 вливаний

- Rp. Dibasoli 0,005 Sacchari 0.2 1). t. d. N. 12  
S. По 1 порошку 3 раза в день

**ЛЮМБАГО (LUMBAGO).** Заболевание мышц нижнего отдела позвоночника. Возникает при сочетании охлаждения и мышечного утомления (прострел).

**Симптомы и течение.** Внезапно наступающая резкая острая боль в локтевом-плечевом области, усиливающаяся при движении, кашле, чихании, натуживании, перемене положения. Острое состояние длится 3—10, дней; заболевание имеет склонность к рецидивам.

**Распознавание.** На основе анамнеза. Необходимо исключить заболевание почек, позвоночника, спинного мозга, гинекологические болезни и радикулит (см.).

**Лечение.** В остром периоде — покой, сухое тепло, соллюкс, синий свет, горячий утюг, мешок с горячим песком, горчичники, банки в поясничную область. Внутрь — пирамидон, анальгин, салициловые препараты. Растирания, инъекции витамина В<sub>6</sub> В упорных случаях — внутрисуставные инъекции 0,25% новокаина (15—30 мл) повторно через 3—4 дня (инъекции производятся в толщу кожи наиболее болезненных участков).

Rp. Pyramidoni  
Analgin aa 0,25  
M. f. pulv. D. t. d. N. 12  
S. No 1 порошку 2 раза в день

Rp. Chloroformii

Methyl salicylic 01. Hyosciami aa 10,0 MDS. Для растирания  
**МЕНИНГИТ (ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК) ГНОЙНЫЙ (MENINGITIS PURULENTA).** Может быть вызван любым гнойным микроорганизмом, проникшим в подпаутинную полость (при воспалении среднего уха, придаточных полостей носа, абсцессе, воспалении легких, пиурии и др.).

**Симптомы и течение.** Заболевание развивается бурно: высокая температура, головные боли, рвота, напряжение затылочных мышц, у детей — судороги. Спинномозговая жидкость гнойная, с огромным количеством гнойных клеточных элементов. **Распознавание** основывается на менингеальном синдроме (см. *Инфекционные болезни, Эпидемический цереброспинальный менингит*), характере спинномозговой жидкости. От эпидемического менингита отличается быстротой течения.

**Лечение.** Холод на голову, горячие ванны, уротропин внутривенно; поясничные проколы\*; внутрь полный курс сульфаниламидов (по 1,0 через каждые 4 часа), витамины (В<sub>6</sub>С). Внутримышечно пенициллин в 1% растворе пирамидона или новокаина три раза в день по 50 000—100 000 единиц и одновременно один раз в день 5 000—10 000 единиц в спинномозговой канал (после выпуска 15—20 мл спинномозговой жидкости). Длительность лечения — 8—10 дней. Тщательный уход; следить за кишечником, избегать пролежней. Прогноз крайне серьезный. Возможны осложнения в виде глухоты, слепоты, водянки головного мозга.

**МЕНИНГИТ СЕРОЗНЫЙ (MENINGITIS SEROSA).** Чаще всего возникает при различных общих инфекциях (тиф, паротит, грипп)

интоксикациях и травме черепа. Иногда возникает при вирусных нейровирусных инфекциях.

**Симптомы и течение.** Менингеальный синдром (см. *Менингит эпидемический*) развивается постепенно на фоне основного заболевания; возможно острое начало. Спинномозговая жидкость прозрачна, при проколе вытекает под большим давлением. Средняя продолжительность заболевания — 2—3 недели. Выздоровление полное. Возможны повторения и осложнения (головные боли, потеря слуха, понижение зрения).

**Распознавание.** Основано на данных клинической картины и исследовании спинномозговой жидкости.

**Лечение.** Лечение основного заболевания, поясничные проколы, внутривенное введение 40% уротропина по 5 мл ежедневно (12—15 вливаний). Пенициллин. Тщательный уход.

**МЕНИНГИТ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ (MENINGITIS TUBERCULOSA).** Генерализация (распространение в организме) туберкулезного процесса и обсеменение оболочек мозга. Чаще всего поражаются дети 1—7 лет.

**Симптомы и течение.** Недомогание, усталость, потеря аппетита, головные боли, рвота. Температура в пределах 38—39°, пульс аритмичный, замедленный; запоры. Постепенно развивается менингеальный синдром (см. *Менингит эпидемический*). Спинномозговая жидкость прозрачная, вытекает под большим давлением; часто через несколько часов выпадает пленка, в которой можно обнаружить палочки Коха.

**Лечение.** Назначение стрептомицина в наиболее ранние сроки заболевания в условиях стационара. Вводится: эндолумбально, в сочетании с внутримышечными инъекциями. Разовая доза эндолумбально 20 000—100 000 единиц (0,02—0,1) в зависимости от возраста. Внутримышечно вводят больным до 3 лет 0,1—0,2 г в сутки, от 3 до 6 лет—0,2—0,25 г, от 6 до 8 лет—0,3 г, свыше 8 лет—0,4—0,5 г (эта дозировка вводится 2—3 раза в сутки через равные промежутки в ягодичную область в течение месяца). Курс, лечения состоит из 18—20 эндолумбальных инъекций в комбинации с внутримышечными инъекциями стрептомицина. Первые 10—12 эндолумбальных инъекций проводятся ежедневно, последующие—через день. В зависимости от состояния, проводят несколько курсов лечения. Весьма эффективным является комбинированное лечение стрептомицином и ПАСК. ПАСК дается взрослым в дозе 12,0—16,0 г в сутки (от 3,6 до 4,0 г на один прием), детям — в дозе до 3,0—6,0 г в сутки (по 1,0—1\*5 г на один прием). Рекомендуется запивать минеральной водой или слабым раствором питьевой соды. ПАСК применяется в течение длительного срока в количествах от 1 до 2 кг на курс. Симптоматически: лед на голову, слабительные, бромиды, препараты кальция, витамины, тщательный уход, полноценное питание.

**МЕНИНГИТ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНЫЙ** см. гл. II *Инфекционные болезни. Эпидемический цереброспинальный менингит.*

**МИГРЕНЬ (HEMICRANIA).** В основе болезни лежат невыясненные периодически наступающие сосудистые изменения в головном

мозгу часто на почве переутомления, голода, психических травм, менструаций, в связи с аллергическими состояниями. Мигрень может начинаться с детства.

**Симптомы и течение.** Периодически наступающие приступы головной боли локализуются чаще в одной половине головы и обычно сопровождаются тошнотой и рвотой. Приступ развивается внезапно, длится несколько часов и чаще всего заканчивается сном.

**Лечение.** Устранение основных причин. Во время приступа: тепло или холод (индивидуально) на голову, стягивание головы; внутрь — мигрофеи, пирамидол, фенацетин, кофеин. В период между приступами — хлористый кальций внутрь или в виде ионизации головы, дарсонвализация головы; внутрь — сосудорасширяющие средства. Диета с ограничением мяса; запрещение крепкого чая, кофе, спиртных напитков, курения; следить за регулярным действием кишечника.

Пр. Diurctini 0,3 Luminali 0,03 M. i. pulv.  
D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 2 раза  
в день

Rp. Zinci valerianic! 1,2  
Extr. Valerianae q. s. ut f. pil. N. 60 DS. По 1  
пилюле 2 раза в день после еды

**МИКРОЦЕФАЛИЯ (MICROCEPHALIA).** Задержка психического и физического развития, обусловленная влиянием на зародыш (инфекции и интоксикации у матери во время беременности). Заболевание может возникнуть в связи с тяжелыми родами.

**Симптомы и течение.** Маленькая голова, преобладание лицевого скелета над черепным, застывшая мимика, повышенного тонуса мускулатуры, нарушение движений, задержка умственного и физического развития.

Прогноз неблагоприятен и зависит от степени поражения головного мозга.

**Лечение.** Хирургическое вмешательство не показано. Воспитательные мероприятия дают незначительные результаты. При судорогах — симптоматическое.

**МИОПАТИЯ (DYSTROPHIA MUSCULORUM PROGRESSIVA).** Заболевание связано с поражением нервной системы и с нарушением эндокринной системы. Встречается у нескольких членов семьи; возникает в детском и юношеском возрасте.

При этой болезни развивается хронический дегенеративный процесс в мышечной ткани, при некоторых формах — в клетках передних рогов спинного мозга и других отделах нервной системы. В основе заболевания предполагают нарушение углеводного обмена. Мышцы плохо усваивают углеводы.

**Симптомы и течение.** Гезко выраженная атрофия мышц спинных, грудных, плечевого и тазового пояса; резкий лордоз (прогибание позвоночника вперед), «утинная походка». Весьма типично вставание с пола ребенка, страдающего миопатией: ста-

новаясь на четвереньки, он разгибает колени и опирается на стоны и ладони; затем, оторвав ладони от пола, опирается ими о поги и, как бы взбираясь с помощью рук по своим ногам, постепенно выпрямляя туловище, переходит в вертикальное положение. Сухожильные рефлексы понижены или вовсе отсутствуют. Болезнь медленно прогрессирует. Предсказание в далеко зашедших случаях неблагоприятное.

Необходимо дифференцировать с полиомиелитом (см.) и полиневритом (си.).

**Лечение.** Массаж, гимнастика, ионогальванизация с кальцием и теплые ванны. Курс инъекций адреналина (1 : 1000), всего 30 инъекций по 1 мл {ежедневно}, усиленная витаминизация (витамины B<sub>1</sub> и E).

С успехом проводится лечение инсулином. Курс лечения состоит из 30 подкожных инъекций инсулина в постепенно возрастающей дозировке: 5 инъекций по 0,2 мл (4 ME), 10 инъекций по 0,4 мл (8 ME), 10 инъекций по 0,6 мл (12 ME) и 5 инъекций по 0,8 мл (16 ME) Спустя 10 минут после инъекции инсулина или пезадолго до нее больному дают внутрь 75—100г сахара. Рекомендуется 3—4 повторных курса лечения с промежутками в 3 месяца. В ряде случаев удовлетворительный эффект получается при лечении иро-зерином.

**МИЭЛИТ ИНФЕКЦИОННЫЙ (MYELITIS).** В основе заболевания лежит острое очаговое или рассеянное воспаление спинного мозга. В большинстве случаев развивается как последствие различных инфекционных заболеваний: тиф, грипп, скарлатина, корь, дизентерия, при вирусных заболеваниях нервной системы, сифилисе и др.

**Симптомы и течение.** Миэлит развивается в любом возрасте, но чаще всего им заболевают люди средних лет. Болезнь развивается остро, за исключением сифилитического миэлита, который развивается обычно медленно. Клинические симптомы различны и зависят от уровня поражения. Чаще наблюдается поперечный миэлит с параличами, расстройством чувствительности, расстройствами сфинктеров, трофическими явлениями и ранним развитием пролежней. Выздоровление медленное, остаточные явления — параличи или парезы.

**Лечение.** Внутривенные вливания 40% раствора уротропина (12—15 вливаний по 5,0 мл через день), 1% раствор трипо-флавина (8—10 вливаний по 5,0 мл внутривенно через день), пенициллинотерапия. Тщательный уход.

**НЕВРАЛГИЯ (NEURALGIA).** Наиболее часто встречается невралгия тройничного, межреберных и седалищных нервов. Анастомические изменения в нервах при невралгии не установлены.

Вызывается острыми и хроническими инфекциями и различными интоксикациями.

**Симптомы и течение.** Наиболее характерными являются приступы острых, жгучих болей, резко обостряющихся при движении и прикосновении. Продолжительность приступов — от нескольких минут до многих часов. При невралгии тройничного нерва боли обычно локализуются в половине лица, при межребер-

ной невралгии острая боль локализуется по межреберьям с одной стороны. Нередко встречается невралгия затылочного нерва.

**Р а с, п о з к а и а л и е.** При болях в области лица необходимо учитывать возможность заболевания придаточных полостей черепа, зубов, периоститы.

При межреберных невралгиях надо исключить плеврит, хроническое воспаление легких, опухоль в грудной клетке, травму, заболевания ребер и др.

**Л е ч е н и е.** Инъекции витамина В<sub>6</sub>. Местно — тепло (грелка, лампа соллюкс). Внутрь — антипирин (по 0,5 три раза в день), пирамидон, бромиды. Физиотерапия—гальванизация, диатермия. В упорных случаях — впрыскивание в нерв 8—10 мл 0,25—0,5% раствора новокаина или спирта. Иногда прибегают к оперативному вмешательству — перерезке нерва.

Rp. T-rae Acoaiti 10,0  
Chloroformii 5,0 MDS.  
Втирать

Rp. Mentholi 0,75  
Cocaini hydrochlorici 0,20  
Chlorali hydrati 0,15 Vaselini 5,0  
MDS. Втирать

**НЕВРАСТЕНИЯ (NEURASTHENIA).** Невроз, характеризующийся повышенной раздражительностью, быстрой утомляемостью. Заболевание обусловлено перенесенными инфекциями, интоксикациями, большой, напряженной работой без отдыха, нередко психогенными травмами.

По Павлову, неврастения соответствует той форме патологической нервной деятельности, при которой нарушен процесс торможения и возбуждения в коре головного мозга. У некоторых преобладают процессы возбуждения (взрывчатость, бурные реакции), у других наблюдаются формы с преобладанием симптомов торможения (апатия, быстрое истощение).

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Головные боли, ощущение стягивания головы, понижение работоспособности, ослабление памяти, трудность сосредоточения, обостренная впечатлительность, быстрая смена настроения, неприятные ощущения во всем теле, иногда половая слабость.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Необходимо исключить другие нервные, соматические и психические заболевания (рассеянный склероз, гипертоническая болезнь, начальные формы психозов и пр.), при которых наблюдаются типичные для неврастении симптомы.

**Л с ч е и и о.** Устранение причинных моментов: переменить обстановку, работу, урегулировать образ жизни, обеспечить правильное чередование работы и отдыха, ограничить курение. Большое значение имеет психотерапия: больному необходимо разъяснить сущность болезни, создать бодрое настроение, внушить уверенность в излечении. Лечебная физкультура.

Эффективным оказывается водолечение: систематические (по утрам) обливания с последующим растиранием, перед сном ванны с хвойным экстрактом температуры 37°, ножные горячие ванны при бессоннице. Внутрь: препараты кальция, глицерофосфаты, мышьяк, железо, спермин, спермокрин, монобромистая камфора и др. Малые дозы брома — 0,5% раствора брома с 0,1% раствором кофеина (М. К. Петрова). В тяжелых случаях больных направляют и специальные санатории.

Rp. Ac. arsenicosi 0,1  
Calcii glycerophosphorici 20,0 Carcphor-ae  
monobromatae 10,0 Extr. Valerianae q. s. lit f.  
pil. N. 100 DS. По 2 пилюли 2 раза в день

Rp. Adonileni 5,0  
Natrii bromati 4,0 Aq. menthae 200,0 MDS. По  
1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Camphorae monobromatae 0,25 Calcii  
glycerophosphorici 0,5 M. f. pulv. D. t. d.  
N. 50 DS. По 1 порошку 3 раза в день

Rp. Sol. Natrii bromati 0,5% 200,0  
Cofeini natrio-benzoici 0,2  
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

**НЕВРИТ (NEURITIS). ВОСПАЛЕНИЕ НЕРВА.** Возникает в результате инфекций (грипп, тиф, малярия, псевдотуберкулезные заболевания), интоксикаций (алкоголь, свинец, мышьяк), травм. Чаще всего встречаются невриты локтевого, лучевого, срединного, седалищного и малоберцового нерва.

При поражении **лучевого нерва** (neuritis n. radialis) кисть отвисает вниз и больной не в состоянии ее разогнуть. Эти невриты встречаются у алкоголиков, иногда после наркоза (если рука больного во время наркоза была неудачно повернута). Длительность заболевания зависит от степени паралича (от нескольких недель до нескольких месяцев).

При поражении **локтевого нерва** (neuritis n. ulnae) у больного развивается «когтистая лапа»: пальцы согнуты, в состоянии их распрямить; отмечается похудание глубоких мышц кисти. На наружной тыльной и ладонной поверхности кисти на коже IV и V пальца понижение всех видов чувствительности. Иногда ощущаются боли. Поражение локтевого нерва чаще всего наступает в результате травмы.

При поражении **срединного нерва** (neuritis n. mediani) затруднено сгибание кисти в кулак, чувствительность расстроена на ладонной поверхности в области трех пальцев<sup>1</sup>.

На нижних конечностях поражается **седалищный** (см. Ишиас) и малоберцовый нерв (neuritis n. peronei).



При неврите малоберцового нерва стопа отгибается вниз и внутрь, больной при ходьбе цепляет носком за землю. При двустороннем неврите малоберцового нерва получается своеобразная походка: больной идет по ровному месту, как бы поднимаясь по ступеням.

**Лечение.** Инъекции стрихнина и витамина В<sub>6</sub>, ноногадвали-запья, парафинолечение, массаж, торфолечение, тепловые процедуры, курортное лечение. При инфекционных невритах — внутривенное введение 5 мл 40% уротропина (15 вливаний через день). Курт «твое лечение (не в остром периоде!)» — Пятигорск, Серно-водск, Манеста, Старая Русса и др.

**НЕВРОЗЫ.** В группу неврозов входят заболевания нервной системы, в развитии которых основную роль играют расстройства высшей нервной деятельности. Согласно учению Павлова, неврозы наступают, когда нарушаются взаимоотношения между тормозными и возбуждающими процессами в деятельности коры головного мозга. Эти нарушения наступают в связи со слишком сильными и сложными раздражителями, при перенапряжениях тормозного процесса при столкновении возбудимых и тормозных процессов. В развитии неврозов исключительное значение приобретают внешние факторы, а характер неврозов складывается по-разному в зависимости от типа высшей нервной деятельности человека. Павлов выделяет четыре типа высшей нервной деятельности: возбудимый, тормозной, а между ними два средних типа и считает, что главными поставщиками различных неврозов являются крайние (возбудимый и тормозной) типы. К неврозам относятся неврастения, истерия, психастения, заикание, страхи, ночное недержание мочи и др.

Весьма часто встречаются неврозы внутренних органов (см. соответствующие разделы). Неврозы наступают при различных неблагоприятных жизненных обстоятельствах, при перенапряжении нервной системы в связи с физическим или психическим переутомлением, при испуге, страхе, травме черепа как результат перенесенных острых заболеваний и при заболеваниях внутренних органов.

**Лечение.** Зависит от характера и клинических проявлений невроза. Рекомендуются общеукрепляющее лечение, перемена обстановки, регулирование труда и отдыха, психотерапия (необходимо разъяснить больному сущность его болезни и способы выхода из болезненного состояния), отвлечение от болезненных жалоб, физиотерапия, физкультура, медикаментозное лечение: комбинация небольших доз брома с кофеином, препараты валерианы.

**НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ (ENURESIS NOCTURNA)** А) зависит от многих причин; чаще всего это невроз, связанный с патологической возбудимостью нервной системы. Порог раздражимости нервной системы настолько понижен, что небольшое количество мочи вызывает рефлекс опорожнения мочевого пузыря. Наблюдается также при эпилепсии, слабости мочевого пузыря, пиелитах и при дефектах позвоночника. Часто встречается у детей; иногда затягивается до полового созревания.

**Симптомы.** Непроизвольное выделение мочи во сне.

**Распознавание.** Необходимо уточнить причину заболевания, обязательно исследовать мочу.

**Лечение.** Лечить основное заболевание. В случаях неврозов хороший эффект дает лечение по методу, предложенному Н. И. Красногорским. До 3 часов дня больному разрешают пить жидкости, сколько он хочет; после этого срока прием жидкости запрещается. В 6 часов больной получает ужин, состоящий из пищевых веществ, не содержащих большого количества воды. Разрешается мясо, свежая рыба, несоленое масло, яйца, немного хлеба; запрещаются овощи, фрукты, каши, соль и соленые блюда — последние два, чтобы не задерживать введенную в организм воду. В 8 часов, когда ребенок уже находится в постели, ему дают соленую пищу: бутерброд с ветчиной, селедкой или с 5 г соли. Не разрешается будить ребенка и прерывать его сон. Недопустимы никакие наказания и упреки, ибо они не достигают цели, а могут вызвать у ребенка чувство неполноценности. При других формах заболевания назначается физиотерапия: гальванизация позвоночника, местное облучение кварцем («трусик»), теплые ванны. Иногда хорошие результаты дает лечение адурькном 0,025 на ночь (3 дня подряд) — вдыхать через нос (этот препарат нельзя применять при подозрении на эпилепсию).

Во всех случаях назначают общеукрепляющее лечение: закаливание, физкультура, инъекции стрихнина; внутрь препараты фитина, кальция, витамины. Необходимо выработать у ребенка навыки опрятности.

Rp. Sol. Strychnin) nitrici 0,1% 1,0 in amp. DS. Для инъекции по 0,5 мл 1 раз в день 20—30 дней

Rp: Phytini

Calcii glycerophosphorici aa 0,25

M. f. pulv. d. t. d. N. 30

S. По 1 порошок 3 раза в день

**НОЧНЫЕ СТРАХИ (PAVOR NOCTURNUS).** Наступают при психических травмах, нарушениях режима питания, сна, затруднении дыхания. Возникают в период раннего детства и прекращаются к 7—8 годам.

**Симптомы.** Ребенок вскакивает ночью, быстро поднимается, широко открывает глаза, от чего-то отмахивается, говорит несвязные слова, плачет, но узнает родных, затем просыпается, а утром обычно не помнит о случившемся.

**Распознавание.** Необходимо дифференцировать с приступами эпилепсии, одним из проявлений которой бывают ночные страхи.

**Лечение.** Устранение основных причин. Не нужно запугивать ребенка, теплые длительные ванны перед сном, регулирование режима, гигиена комнаты и одежды. Внутрь препараты кальция, рыбий жир, люминал (по 0,01 перед сном), бромиды (1-2%).

**ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА (TUMOR CEREBRI).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Общие симптомы (обусловлены повышением внутричерепного давления): головная боль, часто с тошнотой и рвотой, апатия, оглушенность, психическая подавленность; застой-

ше соски зрительных нервов. Местные симптомы (от локализации опухоли): эпилептические припадки, параличи, расстройство речи, выпадение чувствительности, расстройство походки. Течение зависит от характера опухоли. Клинические явления часто нарастают постепенно. Во всех случаях при подозрении на опухоль мозга необходимо направить больного для обследования в больницу.

**Р а с п о з н а в а н и е .** На основании постепенного нарастания симптомов повышения внутричерепного давления. Необходимо исключить: сифилис мозга, начинающийся туберкулезный менингит, ограниченный арахноидит, абсцесс мозга, паразит *m* мозга. Локализация определяется на основании местных симптомов.

**Л е ч е н и е** оперативное. Симптоматически — фенацетин, пирамидол, внутримышечное введение 5% сернокислой магнезии (15—20 инъекций по 5—10 мл), внутривенные вливания 40% глюкозы (10—15 вливаний по 10—20 мл ежедневно). В сомнительных случаях рекомендуется провести специфическое противосифилитическое лечение.

**ОПУХОЛЬ СПИННОГО МОЗГА (TUMOR ME DULL AE SPINALIS).** Симптомы и течение. Симптомы постепенно нарастают. В зависимости от локализации опухоли поражаются те или иные отделы двигательной и чувствительной системы.

Чаще всего бывают боли опоясывающие или по длинику конечности; неловкость при ходьбе и быстрая утомляемость. По истечении некоторого времени наступает полный паралич. Спинномозговая жидкость прозрачна, вытекает под большим давлением, с повышенным содержанием белка при нормальном количестве форменных элементов. Больных с подозрением на опухоль спинного мозга надо направлять в стационар для обследования и хирургического вмешательства.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Необходимо дифференцировать с арахноидитом, миелиомой, сухоткой спинного мозга, сирингомиелиозом, заболеванием позвоночника, множественным склерозом и др. (см.).

**Л е ч е н и е .** Оперативное, как при опухолях головного мозга (см.).

**ПАРАЗИТЫ МОЗГА.** В центральной нервной системе чаще всего встречаются цистицеркоз и эхинококки.

Цистицеркоз мозга протекает многосимптомно. Клиническая картина зависит от количества и локализации паразитов в мозговой ткани. Наиболее частые симптомы: головные боли, судорожные припадки, психические расстройства, иногда менингеальный синдром с поражением нервов основания мозга. Течение медленное, ремиттирующее. Иногда смерть наступает внезапно, и цистицерк является случайной секционной находкой.

**Р а с п о з н а в а н и е** трудное. Ценным диагностическим признаком является эозинофилия в крови и особенно в спинномозговой жидкости, хотя отсутствие ее отнюдь не исключает наличия цистицерка.

Эхинококк. Клиническая картина многообразна, напоминает опухоль мозга и зависит от локализации эхинококка в мозгу. Чаще всего отмечаются головные боли, головокружение, рвота, застойные соски зрительных нервов.

**Г а с и о з и а в а в и с.** Косвенным указанием для диагностики служит общение больного с собаками и другими животными. Некоторое диагностическое значение имеет кожная реакция Катков, которая заключается в разлитом воспалительном отеке на месте впрыскивания в кожу жидкости па эхинококкового H5'зыря. Положительной нужно считать реакцию только тогда, когда она наступает не позже чем через 5—10 минут.

**Л е ч е н и е .** Оперативное.

**П р о ф и л а к т и к а .** Большое значение имеет предупреждение проникновения паразитов в организм человека: санитарный надзор за с/х животными, тщательное мытье овощей и фруктов, мытье рук.

**ПАРАЛИЧ ДРОЙТЕЛЬНЫЙ (PAKALISIS AGITANS).** Разливается исподволь в возрасте 50 лет и старше. Нарастающее дрожание рук и головы, особенно заметное в состоянии покоя, при движениях заедающаяся. Лицо амимичное, повышена саливация, общая скованность; больные передвигаются мелкими шажками, речь монотонная, замедленная.

**В а о , п о з и а в а н и с** не представляет трудностей, следует исключить хроническую форму летаргического энцефалита, которая развивается у более молодых (см. *Энцефалит*).

**Л е ч е н и е .** Подпетые препараты, скополамин в каплях и тн в инъекциях, мышьяк, теплые ванны. В последнее время с успехом применяют димедрол, систематически лечебная физкультура.

Rp. Dimedroli 0,05 Sacclari albi 0,2 M.  
f. pulv. N. 20 S. По 1 порошку 2  
раза в день

**ПАРАЛИЧИ ДЕТСКИЕ МОЗГОВЫЕ (HEMIPLEGIA ET DIPLEGIA SPASTICA INFANTILES).** Органическое поражение центральной нервной системы в связи с внутриутробным поражением мозга, родовым актом (болезнь Диттля) или энцефалитами, перенесенными в первые годы жизни.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Параличи центрального происхождения (мышечная гипертония, высокие сухожильные рефлексы, спастическая походка, контрактуры), сопровождающиеся произвольными движениями; иногда эпилептические припадки, умственная отсталость. Течение хроническое. Прогноз зависит от степени поражения.

**Л с с с и о .** В случаях 'сифилитической' этнологии — антисифилитическое лечение. Общеукрепляющее: теплые ванны, массаж, гимнастика, ортопедические мероприятия для устранения контрактур. Внутрь йодистые препараты: йодистый натрий, йодистое железо.

Rp. Sir. Ferri jodati 15,0  
DS. По 5—8 капель 2 раза в день

Rp. Sol. Kalii jodati 2% 200,0  
S. По 1 десертной ложке -3 раза в день после еды на  
молоке

**ПАРАЛИЧИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ (РОДОВЫЕ).** Возникают при родовом акте как результат травмы (растяжение нервного сплетения при вывихе плеча, переломе ключицы).

**Симптомы и течение.** Плечо повернуто внутрь, конечность свисает и прижата к туловищу, кисть в лучезапястном суставе разогнута. Ладонь открыта, движения пальцев ограничены. Течение благоприятное.

**Распознавание.** Необходимо дифференцировать с центральными параличами (см. *Параличи детские мозговые*) и некоторыми формами ранних параличей на почве врожденного сифилиса, которые развиваются спустя некоторое время после рождения.

**Лечение.** Массаж, пассивная гимнастика начинаются возможно рано и проводятся длительно и упорно.

**ПАРКИНСОНИЗМ** см. гл. II *Инфекционные болезни, Энцефалит.*

**ПОЛИНЕВРИТ (POLYNEURITIS).** Множественное воспаление периферических нервов в результате инфекций (грипп, тиф, малярия, дифтерия, иейровирусные и др.), интоксикаций (алкоголь, свинец, мышьяк), гиповитаминоза В<sub>x</sub>.

**Симптомы и течение.** Встречаются двигательные, чувствительные или смешанные поражения нервов. При первичном инфекционном полиневрите заболевание начинается остро. Температура доходит до 40°, лихорадочное состояние держится несколько дней. С самого начала заболевания отмечается онемение, покалывание, жжение, боли по ходу нервов, параличи. Характерна симметричность и нарастание поражений к дистальным (удаленным от туловища) отделам конечностей. При дифтерийном полиневрите происходит парез (слабость) аккомодации глаза (сужение зрачка при рассматривании близко стоящих предметов), парез мягкого неба; при свинцовом полиневрите — спадание кисти и стопы. В некоторых случаях выздоровление затягивается на несколько месяцев. Иногда остаточные явления в виде нарушенных движений сохраняются на всю жизнь. Гиповитаминозные полиневриты протекают со снижением болевой чувствительности в дистальных отделах конечностей.

**Распознавание.** Следует исключить новнартрит и полиомиелит (см.).

**Лечение.** Лечить основное заболевание. В остром периоде: постельное содержание, теплые местные ванны, внутривенно 40% уротропин по 5 мл, внутримышечно витамин В<sub>j</sub> и подкожно стрихнин, с эффектом применяется тканевая терапия. При болях — Пирамидон, аспирин. Пища — полноценная, богатая витаминами.

При дифтерийных полиневритах иногда благоприятный эффект оказывает сывороточное лечение. Огромное значение имеет уход — в этих случаях необходим длительный абсолютный покой. Но истечении острого периода — массаж, гимнастика, грязелечение, торфолечение, парафинолечение, фарадизация мышц и нервов. Курортное лечение (не ранее чем через 2—3 месяца после острого периода): Пятигорск, Мацеста, Старая Русса. Пр. Vitamini В<sub>x</sub> 0,6% 1,0

Sterilis! D. t. d. N. 15 in amp.

DS. Для внутримышечного введения по 1 мл ежедневно

Rp. Sol. Strychnini nitric! 1:1000 1,0 Sterilis!

D. t. d. N. 30 in amp. S. Для инъекций по 1 мл ежедневно

**ПОЛИОМИЕЛИТ ОСТРЫЙ (POLIOMYELITIS ANTEKIOR ACUTA).** ВОСПАЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ РОГОВ СПИННОГО МОЗГА. Инфекционное заболевание. Возбудитель относится к фильтрующим вирусам. Поражаются клетки передних рогов спинного мозга, ядра продолговатого мозга, иногда и вещество головного мозга. Чаще всего встречается у детей в возрасте до 6 лет.

j

Во время эпидемии встречается и у взрослых. Распространение инфекции происходит кишечным путем и по типу капельных инфекций. Заболевание может передаваться также здоровыми вирусоносителями.

**Симптомы и течение.** Болезнь начинается остро; иногда предшествует общее недомогание. Температура 39—40°, головные боли, рвота, изредка судороги, часто поносы, иногда катарры носоглотки. Острые явления быстро проходят (иногда через несколько часов), после чего выявляются параличи: чаще поражаются ноги, реже руки, иногда рука и нога на одной стороне или перекрестно. Поражаются преимущественно проксимальные (ближайшие к туловищу) отделы конечностей. Нередко поражаются мышцы туловища, шеи и лица. Быстро исчезают сухожильные рефлексы и наступает атрофия мышц.

**Распознавание.** Диагностика в остром периоде затруднена. Часто болезнь диагностируется как грипп; позднее диагностика базируется на характере вялых параличей без расстройств чувствительности (конечность отвисает, как нить). Необходимо дифференцировать с полиневритом (см. *Полиневриты*)

**Лечение.** В остром периоде — постельное содержание не менее 2—3 недель. Для предупреждения контрактур необходимо при помощи шин придать конечности правильное положение. Аутогемотерапия по 15—20 мл ежедневно. Введена сыворотка выздоравливающих по 20 мл в течение 10 дней подряд. При отсутствии данной сыворотки можно с успехом ввести в такой же дозировке коревую сыворотку или гамма-глобулин по 1—2 мл. Внутривенное введение 40% глюкозы с аскорбиновой кислотой. Горячие ванны или укуты вания. Парафинолечение. Через 7—10 дней после начала заболевания нужно начать лечение прозеринем (Sol. Prbserini hydrochloric 0,005%) внутримышечно.

«  
Детям до 4 лет вводят по 0,5 мл, старше 4 лет — от 0,5 до 1,0. Детям грудного возраста назначают инъекции 0,01—0,03% раствора по 0,3—0,5 мл ежедневно в течение 15 дней.

В последнее время в комплексе с физио-ортопедическими средствами с успехом применяют дибазол. Дибазол, назначается в период после развития параличей (два порошка по 0,003—0,005 дибазола ежедневно в промежутках между приемами пищи в течение 15—20 дней). Профилактически, ввиду возможного возникновения пневмонии, назначаются сульфаниламиды или пенициллин. Со 2—3-й недели болезни — легкий массаж и гимнастика. В стадии ре-

«идуальных (остаточных) параличей — итно-ортопедическое лечение. Курортное лечение: Сочи — Мацеста и йр, (не ранее 6 месяцев после острого периода).

**Профилактика.** Обязательная для всех случаев изоляция больного на 6—8 недель, а также дезинфекция помещения, в котором находился больной. Всем детям, бывшим в контакте с больным, ввести SO—60 мл протиплокоревоп сыворотки или родителской крови. В детских коллективах установить ежедневный меди-аинский контроль ва контактными детьми. Дезинфекция выделений, особенно испражнений. О больных посылаются карточки «кстренных извещений».

**РАДИКУЛИТ (RADICULITIS).** Воспаление корешков снга-«шмозговых нервов на почве инфекции и интоксикации. Чаще влего поражаются поясничные, крестцовые, реже — плечевые корешки.

**Симптомы и течение.** Волн, усиливающиеся при растяжении, движении, кашле, перемене положения, при давлении у ныхода церва. При ноясничпо-крестцовом радикулите — ноло-#птельный симптом Кернига и Ласега (болезненность и напряжение мышцы при растяжении нижней конечности). Болезнь имеет на-«'.зность к обострениям.

**Распознавание.** Необходимо исключить опухоль в области корешков (при которой симптомы бывают двусторонними, а течение — прогрессирующим), арахноидит (см.) и заболевания мышц шины — прострел. Заболевания суставов. Во всех случаях аца-гельное рентгенологическое обследование.

**Лечение.** Постельное содержание, местно — тепло, лампа соллюкс, кварц, банки. Внутрь — пирамидон, фенацетин, салици-даты. Подкожные инъекции витамина В]. В затянувшихся случаях — легкий массаж, активная гимнастика, кварцевые облучения, диатермия, гальванизация, парафинотерапия. Хороший эффект дает курортное лечение (в неостром периоде): Цхалтубо, Сериоводск я др.

В р.. Aspirini 0,3  
Pyramidoni Phonacetini aa 0,1 M. I.  
pulv. D. t. d. N. 10 S. Ho 1  
порошку 3 раза в день

P. p. Methylii salicylic! 01.  
Hyoscyarni Chloroformli  
aa 15,0 MDS. Втирание

8p. Ichthyoli 10,0  
Ac. salicylici 0,1  
01. Tcrebinthinae 10,0  
Vasellini 100,0  
M. I. ung.  
DS. Мазь

а&gt;

**СИРИНГОМИЭЛИЯ (SYRINGOMYELIA).** Хронически прогрес-  
сирующее заболевание спинного мозга с образованием полостей в  
сером веществе его.

**Симптомы и течение.** Утрата болевой и температурной  
чувствительности при сохранении осязательной чувствительности на  
туловище и конечностях. Атрофические параличи, чаще всего мелких  
мышц, конечностей; трофические расстройства в виде язв и  
деформаций суставов, следы ожогов на анестезированных участках  
кожи, сколиозы (искривления позвоночника в сторону) с ;'.формацией  
грудной клетки.

**Распознавание и е.** Дифференцировать с опухолью спинного  
мозга (см.), -сухоткой спинного мозга (см.).

**Лечение.** Рентгенотерапия на ранних этапах болезни дает  
удовлетворительный эффект. Электризация и массаж паретических  
(парализованных) мышц. Внутрь препараты мышьяка, фосфора, железа.  
Перевод на легкую работу, освобождение от работы в горячих цехах.

**СИФИЛИС НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (NEUROLUES).** К л и и к а и  
т о ч е н и е.. Вызывается бледной спирохетой. Согласно Последним  
данным, нервная система поражается, начиная с первых недель  
заболевания. Головной мозг поражается чаще, чем спинной. При  
сифилитических поражениях мозга, развивающихся в течение первых  
лет после заражения, наблюдаются головные боли, головокружение,  
шум в ушах, рвота, невралгически- болп, раздражительность,  
бессонница. При более поздних формах заражения перинной системы  
чаще всего развивается гуммозный базиллярный менингит, который  
сопровождается упорными головными болями (особенно по ночам) и  
поражением глазодвигательного, отводящего, лицевого и слухового  
нервов. В этом же периоде наступают сосудистые изменения мозга,  
которые сопровождаются парезом, параличами, расстройством  
чувствительности, эпилептическими припадками и инсультами. К  
поздним формам сифилитического поражении нервной системы  
относится сухотка спинного мозга (см.) и прогрессивный паралич (см.  
*Психические заболевания*). При врожденном' сифилисе, кроме общих  
симптомов, характерных для этого заболевания (см. *Сифилис*),  
встречается гидроцефалия, параличи, эпилептические припадки,  
психическая отсталость.

**Распознавание** основывается на множественности очагов,  
данных анамнеза и серологических реакциях. Необходимо исключить  
энцефалит, множественный склероз (см.).

**Лечение.** Специфическое в сочетании с инъекциями пе-ип-  
цилина (см. *Сифилис*).

**СКЛЕРОЗ МНОЖЕСТВЕННЫЙ (SCLEROSIS MULTIPLEX).**  
Наиболее вероятно инфекционная природа заболевания с образованием  
бляшек в белом веществе головного и спинного мозга. Возбудитель —  
фильтрующий вирус.

**Симптомы и течение.** Заболевания в большинство случаев  
начинается в возрасте 20—40 лет. Течение — медленное, временами  
обостряющееся. Симптомы непостоянные, зависящие от локализации и  
стадии заболевания. Чаще всего отмечается быстрая утомляемость,  
нарастающая слабость в ногах, спастический нарапа-

ресз ног, гипертония, дрожание в руках, растянутая речь, переходящая слепота, нистагм (непроизвольные подергивания глазных яблок), отсутствие брюшных рефлексов; часты ухудшения состояния. Болезнь может затянуться на много десятков лет, в редких случаях смерть наступает быстро.

**Лечение.** 40% уротропин по 5 мл внутривенно через день. Рентгенотерапия, инъекции прозерина. В ранних случаях вакцино-терапия. Три цикла вакцинации по 4 инъекции в каждом. Инъекции проводятся через 3—4 дня по 3—5 мл. Промежутки между циклами 2—3 недели. С успехом проводится лечение (внутримышечное введение) лаковой кровью (кровь больного, разбавленная дистиллированной водой). Многие авторы с эффектом применяют тканевую терапию. Общеукрепляющее: мышьяк под кожу, теплые ванны. Рекомендуются перевод на легкую работу.

**СУДОРОГИ (SPASMUS).** Наблюдаются при менингитах, энцефалитах, новообразованиях мозга, расстройствах кровообращения и заболеваниях мозговых сосудов, при отравлениях (у детей раннего возраста при пищевых отравлениях), тяжелом рахите (спазмофилия); у грудных детей часто при любом повышении температуры, при эпилепсии.

Судороги бывают местные — изолированные — или генерализованные, охватывающие значительную группу мышц. Судороги при эпилепсии часто протекают с потерей сознания. При некоторых профессиях (машинистки, стенографистки, пианисты, портные, телеграфисты) наблюдаются «профессиональные судороги». В этих случаях в судорогу вовлекаются мышцы кисти, предплечья, плеча, возникает тоническое напряжение мышц и слабость, вследствие чего больные вынуждены менять профессию.

**Распознавание** — на основании анамнеза и клинических данных. Следует быть весьма осторожным в предсказаниях, особенно у детей раннего возраста. Не все судороги детского возраста относятся к спазмофилии, которая редко развивается до 4 месяцев и позже 3 лет. Для выяснения глистной интоксикации у детей необходимо исследовать кал на яйца глистов.

**Лечение.** Лечить основное заболевание. Во время приступа — покой, клизма из хлоралгидрата (после очистительной клизмы медленно ввести 100 мл 2% раствора хлоралгидрата). Вне приступов — препараты кальция, фитин, бромистый натрий, рыбий жир, небольшие дозы люминала, теплые ванны с хвойным экстрактом.

**СУХОТКА СПИННОГО МОЗГА (TABES DORSALIS).** Сущность болезни заключается в воспалительных и дегенеративных изменениях задних столбов спинного мозга и нервных корешков, наступающих через 5—15 лет после перенесенного сифилиса.

**Симптомы и течение.** Опоясывающие боли грудной клетки, стреляющие боли в ногах. Приступы резких болей в животе, расстройство мочеиспускания, шатающаяся походка, неравномерность или утрата коленных рефлексов, симптом Аржиль-Роберт-сона (отсутствие реакции зрачков на свет при наличии реакции на конвергенцию и аккомодацию) и атрофия зрительных нервов.

**Распознавание.** Сифилис в анамнезе. Дифференцировать с опухолью спинного мозга, с остаточными явлениями полиневрита (см.).

»

**Лечение** — специфическое. Лучше всего инъекции биохимопола (12—15 инъекций по 2—3 мл через два дня на третий). Курс лечения необходимо проводить повторно (подробно см. *Сифилис*). В промежутках между курсами — йодистое лечение. Гальванизация позвоночника, фарадизация мочевого пузыря. Инъекции стрихнина. При сильных болях — аспирин, фенацетин, пирамидон. Избегать наркотиков. Массаж, гимнастика. Курортное лечение в Пятигорске, Мацесте, Одессе.

Особое значение имеет режим. Избегать охлаждения (не выходить в сырую погоду без Калош, не купаться в холодной воде). Воздерживаться от переутомления. Необходим достаточный отдых, сон и полноценное питание.

**ТИКИ.** Непроизвольные подергивания членов тела. Обычно появляются после энцефалитов и истощающих инфекционных болезней, в связи с психическими травмами, при невралгиях, а у детей — часто при подражании. Начинаются в возрасте 5—6 лет.

**Симптомы.** Чаще всего тики наблюдаются на лице, далее в области шейной и нередко в области дыхательной мускулатуры.

**Распознавание.** Ввиду того что тики могут быть симптомом перенесенного энцефалита (эпидемического), необходимо тщательно обследовать нервную систему.

**Лечение.** Общеукрепляющее (мышьяк, железо), симптоматическое (бромиды), физиотерапия (местное тепло).

#### ТРАВМЫ МОЗГА (COMMOTIO, CONTUSIO CEREBRI).

**А. Травмы головного мозга.**

Сотрясение мозга (commotio cerebri) наступает при ударе головы и при воздушной контузии от разорвавшегося снаряда.

**Симптомы.** Бессознательное состояние, поверхностное дыхание, замедленный пульс, рвота; сухожильные рефлексы вызываются. Продолжительность бессознательного состояния зависит от тяжести травмы и длится от нескольких минут до многих часов. В свете учения И. П. Павлова потеря сознания при травмах мозга рассматривается как результат экстренного торможения защитного характера. Приходя в себя, больной ничего не помнит ни о травме, ни о событиях, непосредственно предшествовавших ей. Не восстановлению сознания — головные боли, рвота, головокружение при перемене положения, раздражительность, быстрая утомляемость, сердцебиение, потливость, иногда очаговые симптомы в зависимости от места поражения. В тяжелых случаях больной может погибнуть, не приходя в сознание; в случаях средней тяжести полное исчезновение всех симптомов может длиться до 1 года.

**Ушиб мозга (contusio cerebri).** Резкой границы между сотрясением и ушибом мозга провести нельзя. При ушибах мозга наблюдаются более грубые симптомы: парезы, параличи, нарушение чувствительности.

**Лечение.** В остром периоде — полный покой, холод на голову; при возбуждении — бромиды, люминал, 40%, раствор глюкозы, 40—40 мл внутривенно или в сочетании с 5% раствором сернокислой магнезии (Vs глюкозы и  $\frac{1}{8}$  сернокислой магнезии). Внутрь пирамидон, фенацетин. При резких головных болях — осторожно люмбальная пункция (отпустить 8—10 мл спинномозго-

вой жидкости), тщательный уход, наблюдение за сердечной деятельностью, полноценное питание. Очень большое значение имеет длительный постельный режим (до 1 месяца), а затем постепенный переход к обычной жизни. При остаточных явлениях и повышенной возбудимости — кальций и глюкоза (10—12 вливаний на курс).

**В.** Травмы спинного мозга. При сотрясениях и ушибах спинного мозга встречаются парезы, параличи, расстройства чувствительности и изменение рефлексов. При кровоизлиянии в спинной мозг эти симптомы более резко выражены, (давление спинного мозга и при травме позвоночника ведет к тяжелой картине поперечного миелита с полной спастической параплегией, расстройством всех видов чувствительности и развитием пролежней).

**Лечение и с.** Полный покой (на горизонтальной твердой поверхности (доска), покрытой матрацем), тщательный уход, борьба с пролежнями и циститом. Следить за кишечником. Пенициллин и сульфаниламиды, лечебная физкультура, массаж. При показаниях — оперативное вмешательство. В случае остаточных явлений — повторные курсы лечения на грязевых курортах (Саки, Евпатория, Одесса, Пятигорск и др.).

**ХОРЕЯ (CHOREA MINOR).** Заболевание инфекционное. Возбудитель неизвестен, установлена тесная связь с суставным ревматизмом и эндокардитом. Чаще всего заболевают дети в возрасте 5—15 лет, преимущественно девочки. Иногда наблюдается у беременных.

**Симптомы и течение и с.** Болезнь развивается постепенно, иногда начало острое. Основные симптомы: непроизвольные, неkoordinированные (нессоразмеренные) движения в мышцах лица, туловища и в конечностях. В подергивании принимает участие язык и мышцы гортани, вследствие чего глотание нарушено и речь неотчетлива, часто с носовым оттенком. В тяжелых случаях наблюдаются непрерывные непроизвольные движения в мышцах туловища, рук и ног. С первых дней заболевания отмечается изменение психики: раздражительность, ел вливост, обидчивость, упрямство, смена настроения. В продромальном периоде — слабость, быстрая утомляемость, разбитость, иногда сонливость или бессонница. Эти состояния могут быть раскрыты в свете учения И. П. Павлова как нарушение основных процессов корковой нейродинамики. Болезнь часто сочетается с пороком сердца. Течение 8—10 недель, отмечается склонность к повторениям.

**Распознавание и с.** Дифференцировать с остаточными явлениями после энцефалита (см. *В энцефалит*). Необходимо учитывать, что первоначальные симптомы часто неправильно рассматриваются как детские капризы.

**Лечение и с.** Полный покой, постельное содержание; витаминизация; аутогемотерапия; теплые ванны; салициловые препараты, люминал, препараты мышьяка, бромиды, кальций, внутримышечно 5% раствор сернокислой магнезии — 5 мл (10—15 инъекций). Сульфаниламидные препараты, пенициллин, пирамидол (по 0,2 шесть раз в день в течение 2—4 дней). Усиленное полноценное питание с достаточным содержанием витаминов. Лечение сном.

**Вр. Sol. arsenicalis Fowleri 5,0 T-rae Ferri pomati 20,0 MDS.** По 15 капель 2 раза в день

**Rp. Ac. arsmicosl 0,05  
Calcii glyceiophosphorici 20,0 Camphorae monobromatae 10,0 Kxtr. Valerianae q. s. ut f. pil. N. 100 DS.** По 1 пилюле 2 раза в день

**ХРОМОТА ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ (СЪАШСАТШ INTERMITTENS).** Симптом и течение. Постепенно нарастающая слабость и боль в ногах. Резкие боли в икроножных мышцах, увеличивающиеся при движении. Иногда спазмы в сосудах мозга и других органах.

**Распознавание.** Приступообразные боли по время ходьбы, ослабление и исчезновение пульса на тыльной артерии стопы.

**Лечение.** Препараты иода, папаверина, диуретина, нитриты, инъекции витамина В<sub>6</sub>, гальванический воротник по Щербаку. Сероводородные ванны. Исключение курения, охлаждения и чрезмерного физического и психического напряжения.

**ЭНЦЕФАЛИТЫ** см. гл. II *Инфекционные болезни*.

**ЭПИЛЕПСИЯ (EPILEPSIA). ПАДУЧАЯ БОЛЕЗНЬ.** Развивается при травме головы, родовой травме, шифекциях, интоксикациях и опухолях мозга.

**Симптомы и течение.** Приступы с внезапным расстройством сознания, общими судорогами, во время которых у больного часто наблюдается прикусывание языка, пенная слюна и недержание мочи. Иногда приступу предшествует период предвестников, так называемая «аура» (слуховые, зрительные, осязательные раздражения). Эпилептический припадок длится несколько минут, после чего обычно наступает длительный сон. Проснувшись, больные не помнят о происшедшем. Иногда припадки быстро следуют друг за другом (эпилептическое состояние). Припадки возникают через неравномерные промежутки. Иногда в течение жизни отмечаются лишь единичные припадки.

По И. П. Павлову, судорожный эпилептический припадок связан с патологической инертностью известного пункта двигательного анализатора коры головного мозга. Ночные эпилептические припадки объясняются тем, что в состоянии бодрствования инертный пункт недостаточно силен, чтобы обнаружить свое действие на нормальную деятельность коры, а проявляется только ночью, когда возбуждение коры ослаблено. Сильное душевное возбуждение, переутомление, недостаточное проветренное помещение, неурядок со стороны кишечника (запоры) и другие вредности могут провоцировать приступы. Наряду с судорожными большими припадками, встречаются также и малые, во время которых больной на несколько секунд теряет сознание, прерывает нить разговора, смотрит в одну точку, а затем как ни в чем было продолжает прерванную фразу. В период между приступами у больных отмечаются определенные черты характера: прилипчивость, черствость, злобность, аккуратность, доходящая до педантизма, вспыльчивость.

Течение хроническое. Особо следует выделить кожевниковскую эпилепсию, которая в большинстве случаев связывается с клещевым энцефалитом. В этих случаях в периоде между большими припадками наблюдаются постоянные клонические судороги в какой-либо мышечной группе (*epilepsia partialis continue*).

**Распознавание.** Все случаи требуют тщательного исследования. Необходимо исключить истерические припадки, при которых реакция зрачков на свет сохранена, больной не ушибается, не упускает мочи и не прикусывает языка. У детей нужно исключить судороги, связанные с рахитом, ларингоспазмом, спазмофилией и другими состояниями. Склонность к припадкам у детей до 3 лет, не связанная с грубым нарушением в центральной нервной системе, обычно бесследно исчезает. Юношеские эпилептические припадки также часто исчезают к окончанию полового развития. Прогноз неблагоприятен, когда припадки начинаются в зрелом возрасте.

**Лечение.** В случаях рубцов, спаек, опухолей в мозгу — оперативное вмешательство. Во время припадка необходимо подложить под голову мягкий предмет; предварительно, до сведения челюстей, нужно вложить между зубами в несколько раз сложенный угол носового платка (чтобы больной не прикусил языка), расстегнуть ворот рубашки, пояс, шнуровки, стесняющие дыхание. Ничего не вливать в рот. При длительном приступе — клизмы из хлоралгидрата. Во время припадка нельзя тревожить больного. Вне припадков — люминал (по 0,05 два раза в день), кальций, бромистый натрий, бура.

В последнее время с успехом применяют дн л ангин по 0,1 один\* два раза в день в течение месяца, а также таблетки д-ра Кармановой (таблетки № 1 при частых припадках — по 1 таблетке 2—3 раза в день, таблетки К\* 2 при редких припадках — по 1 таблетке 2—3 раза в день (подробно смотри инструкцию, разосланную по месту).

**Лечение** длительное и упорное. Следить за кишечником, изъять из ниши все возбуждающее, спиртные напитки. Во избежание нанесения увечий себе и окружающим этим больным и запрещается работать на высоте, у огня, у машины, в качестве водителей транспорта. При тяжелой психической деградации\*больного необходимо поместить в специальные стационары.

Rp. Sol. Kalii tartaric! boraxat'i 20,0:300,0 DS. По 1 столовой ложке 3 раза в дгпъ

Pr. Boracis 1,0  
D, t. d. N. 30  
S. По 1 порошок 3 раза в день

lip. Dipheninis 0,1  
DS. По 1 порошок 2 раза в день

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rp. Luminali 0,05                | Rp. Chlorali lrydrati 4,0        |
| Coffc-. Ji. natrio-benzoici 0,02 | Mucilago Ctumm -arabici          |
| M. f. pulv. N. 12                | Aq. f <sub>ontanae</sub> aa 75,0 |
| S. По 1 порошок 3 раза в день    | мDS. На 2 клизмы                 |

## ГЛАВА IV

### ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

**АЛКОГОЛЬНЫЕ'- ПСИХОЗЫ.** Психические расстройства возникают как при остром, таї; и при хроническом отравлении алкоголем.

**1. Алкоголизм хронический. Э т и о л о г и я и п а т о г е н с з.** При хроническом алкоголизме имеется значительное нарушение корковой динамики: ослабление замыкательных функций, патологическое понижение подвижности корковых процессов, недостаточность процессов активного торможения. Наблюдаются фазовые пилиния как в первой, так и во второй сигнальной системе, что указывает на наличие охранительного торможения в коре головного мозга (А. Г. Иванов-Смоленский). Болезненные нарушения особенно выражены по второй сигнальной системе.

**С н м п т о м ы.** Понижение работоспособности. Ы нлоцепо мышления, снижение памяти и внимания. Неустойчивость настроения, раздражительность. В силу торможения высших корковых функций— речевое возбуждение со стремлением к юмору, грубым шуткам. Этическое снижение и постепенная деградация. Редким спутником является так называемый бред ревности пьяниц. Головные боли, головокружение, расстройство речи, дрожание рук и языка, расстройство сна. Из общесоматических расстройств — катарр желудочно-кишечного тракта, поражение печени и почек, снижение половых функций.

Течение длительное, зависит от создания условий для полного отнятия алкоголя, от психосоматической устойчивости организма, количества и концентрации поглощаемого алкоголя.

**Л с ч е и с.** Связано прежде всего с полным отнятием алкоголя. Начинать лечение следует амбулаторно, в психоневрологических диспансерах, в случае неудачи — в специальном стационаре. Уместны психотерапевтические беседы, в ряде случаев — гипноз. Рекомендуется коллективный гипноз., который более эффективны иі (в силу взаимной индукции) и экономит время врача. Необходимо подчеркнуть важность социально-воспитательных мероприятий. Большое значение имеет трудовая терапия. Наряду с общеукреп-Яяющими средствами, применяется водолечение (обмывание и обтирание холодной водой), обильное питание, растптельнб-молочпля днэта.

Из общеукрепляющих и тонизирующих средств рекомендуется;

Pr. Sol. Nalrii kakodylici 2% 10,0 Strjtis\*  
tur! DS. По 1 мл под кожу ежедневно

Кислород 200—300 мл подкожно 2—3 раза в неделю.

Благоприятные результаты дает сочетание лечения сном с бесшоковой инсулинотерапией (А. Г. Ивандов-Смоленский).

Большим шагом вперед явилось использование метода условных рефлексов И. П. Павлова: сочетание рвотных средств (апоморфина и пр.) с дачей алкоголя. Для образования эмоционально-отрицательной и рвотной реакции требуется от 5 до 40 сочетаний во времени зрительно-обонятельно-вкусового раздражения, вызываемого алкоголем в сочетании с апоморфином. Минимальная рвотная доза апоморфина колеблется от 0,25 до 0,5 мл 1% раствора под кожу. В тех случаях, где апоморфин вызывает особенно тяжелые вегетативные реакции, он должен быть заменен эметинотом или ипекакуаной. Лечение проводится в условиях стационара. Этот метод значительно повысил эффективность лечения хронического алкоголизма. Противопоказанном к применению данного метода являются: язвенная болезнь, туберкулез легких со склонностью к кровотечению, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, пожилой возраст.

При явлениях возбуждения (беспокойство, страх, дрожание рук, бормотание), наряду с постельным режимом, следует назначать барбитураты или хлоралгидрат.

2. Беспамятность. Этиология и патогенез. Возникает исключительно на почве хронического алкоголизма. Промежуточным этиологическим фактором часто является расстройство обмена веществ, в частности, нарушение функций печени. Предрасполагающими причинами считаются лихорадочные заболевания, резкое эмоциональное возбуждение. Галлюцинации обычно относятся главным образом к первой сигнальной системе и развертываются на фоне состояния, промежуточных между бодрствованием и сном.

Симптомы. Изменение общего самочувствия, тревога, беспокойство, неопределенные страхи, расстройство сна — таковы нередко предвестники белой горячки. Чаще отмечается острое начало, когда (обычно ночью) изменяется сознание больного и появляются обильные галлюцинации, главным образом зрительного характера. В дальнейшем такие галлюцинации возникают и днем. Для этих галлюцинаций характерны малые размеры, яркость, сценичность, подвижность (преобладают мелкие животные, насекомые). Галлюцинации большей частью неприятного, угрожающего характера, иногда фантастического содержания. Нередки галлюцинации осязания (ползание мурашек, шевеление под кожей) и галлюцинации, связанные с нарушением равновесия (рушится потолок, стоны и т. п.). Реже слуховые обманы угрожающего и упрекающего характера. Галлюцинации ведут к бредовому, извращенному толкованию действительности. Больные передают воспроизводит сцены, отображающие их обычные занятия («профессиональный бред»). Вся картина сочетания страха и юмора. Двигательное и речевое беспокойство. Сознание изменено; ориентировка, особенно в месте, расстроена. Дрожание рук, повышенная чувствительность к болевым раздражителям, нередко эпилептиформные припадки, особенно в начале заболевания, тяжелые нарушения сна, страх.

»

Течение острое, приступы проходят в течение 3—8 дней. Выздоровление наступает сразу, во сне (так называемый критический сон).

Лечение. В первые дни, имея в виду внезапные попытки к бегству, самоубийству и пр., назначают постельный режим и тщательный надзор. Особое внимание нужно уделить сердечной деятельности: рекомендуется строфант, камфора, кофеин, наперстянка. При угрожающем состоянии сердца, наряду с сердечными средствами, дают алкоголь.

Bp. Spiritus Vini rectificati 96% 20,0

DS. По 10 капель на полстакана воды Для купирования белой горячки прибегают к вызыванию длительного (на протяжении 15—20 часов) критического сна по следующей прописи:

Rp. Hexenali 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. Растворить содержимое 1 ампулы в 10 мл свежеприготовленной дистиллированной воды, вводить 10 мл внутримышечно (в область ягодицы) или 5 мл внутривенно

Раствор гексенала следует вводить в вену медленно, не быстрее 2 мл в минуту, иначе могут появиться угрожающие симптомы: бледность, цианоз, остановка дыхания и возникнет опасность коллапса, даже угроза смерти.

Если больной просыпается, ему следует немедленно дать 0,1—0,2 люминала.

При возбуждении, связанном с двигательным беспокойством и бессонницей, рекомендуется назначение барбитуратов, при болевом интенсивном возбуждении: — хлоралгидрат: Rp. Chloralhydrati 3,0

Mucilage's gummi arabici

Aq. destill: aa 50,0

ML) S. По 1—2 столовых ложки на прием

Следует иметь в виду, что частое назначение хлоралгидрата может вызвать привыкание к препарату и снижение артериального давления. Не следует пользоваться опиатами, вызывающими запоры, а также обертываниями, которые нередко усиливают состояние страха.

3. Корсаковский психоз. Этиология и патогенез. Чаще всего и в наиболее выраженной форме наблюдается описанная С. С. Корсаковым картина, которая возникает на почве хронического алкоголизма и носит название корсаковского психоза. Наряду с корсаковским психозом, этой единой в этиологическом и клиническом отношении группы случаев, наблюдается еще так называемый корсаковский синдром, который наблюдается при многочисленных инфекциях, травмах черепа, артериосклерозе головного мозга, опухолях мозга и пр. При корсаковском синдроме имеет место значительное торможение определенных мозговых систем, нарушение их целостной деятельности, что является препятствием



к образованию новых связей. В состоянии хронического торможения выявляются различные гипнотические фазы. Резко выделяется парадоксальная фаза, когда реакция на более слабые раздражения, например, па следы многолетней давности, резче выражена и способна к воспроизведению, в то время как сильные раздражители — текущие события — совсем не оставляют следов в нервной системе.

**С и м п т о м ы .** Расстройство способности к запоминанию нового, свежих впечатлений, ретроградная амнезия<sup>1</sup>, расстройство ориентировки го времени и месте, копфабуляции<sup>2</sup>, постепенное снижение интеллекта. Сознание ясное. Со стороны сома гики нередко полиневриты.

**Тече п и е.** Развивается постепенно и может длиться в течение ряда лет без значительных колебаний. Полное восстановление наблюдается редко, обычно остаются дефекты памяти и восприятия. В более легких случаях наступает выздоровление без ., дефекта.

**Лечение .** В основном сводится к уходу, в остальном — симптоматическое. Первое время постельный режим, теплые ванны. Из лекарств: 0,1% раствор стрихнина по 0,5 мл под кожу один раз в день, а также витамин В<sub>1</sub>, глюкоза, кофеин.

**АРТЕРИОСКЛЕРОЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ГИПЕРТОНИЯ.** **Этнология и патогенез .** В возникновении артериосклероза существенную роль играют экзогенные вредности (физические и психические), а также слабость сосудистого аппарата.

**С и м п т о м ы .** Ослабление памяти, в особенности запоминания нового, падение работоспособности, инициативы. Неустойчивость настроения, нарастающее слабодушие, слезливость. Колебания интенсивности симптомов. Походка становится неуверенной, наблюдается дрожание рук и языка, неравномерность и вялая реакция зрачков и ряд более грубых неврологических симптомов в случаях с Определенными очаговыми поражениями. Характерный симптом — головные боли, головокружение, шум в ушах п голове, расстройство сна. При тяжелых формах артериосклероза важную роль приобретают инсульты (см. *Инсульт*). В психике можно наблюдать нарастающее снижение, доходящее в отдельных случаях до слабоумия. Артериосклеротическое слабоумие отличается в ряде случаев очаговостью: долго сохраняется «ядро» личности, остаются сохранными некоторые навыки и знания, налицо критическое отношение к своей болезни. Помимо этого, при тяжелых формах могут развиваться состояния депрессии, иногда с бредовой окраской, реже состояния возбуждения с помрачением сознания, приступами страха.

**Течение** хроническое; в одних случаях медленное, сравнительно благоприятное, с длительными периодами стационарного состояния, в других — неуклонно прогрессирующее ухудшение.

**Лечение .** В легких случаях такое же, как при общем артериосклерозе. Наряду с медикаментозным и физиотерапевтическим

<sup>1</sup> Ретроградная амнезия — потерн памяти на событл, предшествовавшие началу болезни, и ослабление пли расстройства вообще памяти.

<sup>2</sup> Конфабуляции (лат. сказка, басня) — лож.ше (паи бы вымышленные) во-п минания.

лечением, большую роль играет психотерапия: больные требуют в первую очередь успокоения и утешения. Пока возможно, их не следует снимать с обычной работы. Из лекарственных средств применяют йодистые препараты.

Rp. T-ra Jodi 10% 10,0 pro  
usu interno

DS. Но 3—5 капель на молоке 2—3 раза в день после  
еды

Pr. Diurctini 0,3 Kali'i  
jodati 0,1 M. f. putv.

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку 3—5 раз в день в течение месяца, а  
затем месячный нерерыв

Если указанные средства не помогают, то, наряду с ними, назначают: а) кровопускание в количестве 200—300 мл, б) пиявки к копчику (5—8) или за уши (4—6).

В возникновении г и п е р т о н и и отмечается сочетание различных вредностей — психических травм, повторных инфекций, переутомления и пр. В патогенезе наблюдаются функциональные нарушения пазомоторных аппаратов коры и подкорки типа неврозов по Павлову, главным образом сосудистых аппаратов головного мозга, обуславливающих спазм сосудов на периферии, с последующими анатомическими -изменениями в поздние фазы заболевания. При начальной фазе гипертонической болезни процесс возбуждения и высших отделах головного мозга превалирует над процессом торможения, при дальнейших фазах имеет, наоборот, место преобладание тормозного процесса.

**С и м и т о м ы .** Наряду с повышенным кровяным давлением, отмечается более пли менее резкое снижение работоспособности, повышенная утомляемость и истощаемость, аффективная неустойчивость, ослабление памяти, наклонность к головокружениям и головным болям, к приливам крови к голове.

**Лече н и е .** При доброкачественных г и п с р т о н п я х рекомендуется применение следующих препаратов.

P.p. Salsolini (S. Salsolidini) hydrochlorici 0,03

Sacchari albi 0,2 M. i. pulv. D. t. A. N. 20 S. По 1  
порошку 3—5 раз в день

Rp. Diuritini 0,3 Luminali 0,03 M. f. pulv. D.  
t. d. N. 20 S. Но 1 порошку 3—5 раз в  
день

Ограничить прием жидкости. При резком возбуждении.— постельное содержание и ванны.

Из физиотерапевтических мероприятий (как для артериосклероза, так и для гипертонии): а) общая дарсонвализация; б) диатер-

мая головы; в) гальванизация; г) теплые углекислые или соляно-щелочные ванны; д) четырех- и двух-камерные ножные ванны.

**ИНТОКСИКАЦИОННЫЕ ПСИХОЗЫ.** Этого рода психозы наблюдаются после отравления наркотиками (см. *Алкоголизм. Кокаинизм, Морфинизм*), лекарственными, пищевыми и промышленными ядами.

1. Острые интоксикации см. *Первая помощь при острых отравлениях*.

2. Психозы, возникающие на почве хронической интоксикации

**О с о с е и и о с т и п с и х о з ы** при различных видах отравлений \* Акрихин. **С и м п т о м ы**. Отравление акрихином наблюдается в отдельных случаях в связи с его передозировкой в процессе терапевтического применения. Самый частый синдром при хроническом отравлении — маниакальный, в ряде случаев встречающийся на фоне ясного сознания. Менее часты амепсивный и эпилептиформные синдромы (см. *Синдромы, Добавление II*).

Антифриз (принадлежит к очень тяжелым ядам). **С и м п т о м ы**. Вслед за кратковременной эйфорической стадией наступает тяжелое оглушение, нередко переходящее в коматозное состояние и заканчивающееся смертью. В благоприятных случаях болезнь заканчивается длительным астеническим состоянием.

Лтронин. **С и м п т о м ы**. Наблюдается делириозное помрачение сознания со зрительными галлюцинациями неприятные ощущения в коже, веселое настроение или страти характерное возбуждение, сопровождающееся криками в агрессивностью, судороги и пр. После короткого промежутка времени появляется ступор (в отдельных случаях наступает смерть) или же сознание начинает постепенно проясняться и остается лишь частичная амнезия.

Барбитураты. **С я м и т о и ы**. При хроническом отравлении психическая картина напоминает прогрессивный паралич: расстройство речи, счета, памяти, расстройство реакции зрачков на свет и пр. При длительном отравлении — делирий (?м. *Синдромы, Добавление II*), эпилептиформные припадки.

Бром. **С и м п т о м ы**. При длительном пользовании бромом может наступить отравление. Короткий период повышенного настроения сменяется периодом пониженного настроения, сопливости; отмечается расстройство речи. Постепенно развертывается картина помраченного сознания, роже спутанности, появляются бредовые идеи. В отдельных случаях отмечается резкое похудание.

Оксись углерода. **С и м п т о м ы**. Больные становятся делириозными, спутанными, а в дальнейшем чаще всего развертывается амнестический синдром. В других случаях имеется резкое бредообразование (бред преследования), реже — картина псевдопаралича. Выздоровление бывает неполным, длительное время остается понижение активности, памяти, аффективная тупость.

Твтраэтилсплещ (ТЭС) принадлежит к промышленным ядам. **С и м п т о м ы**. Особенно характерны переживания страха с бредовыми высказываниями о предстоящей гибели — своей и родных а также делирии с яркими зрительными и тактильными галлюцина-

днями. Постепенно атактически явления усиливаются. Возникает тяжелое оглушение сознания с резким психомоторным возбуждением и последующей полной амнезией. Обнаруживаются трофические расстройства, температура поднимается до 40° и выше, и в этих случаях больной нередко погибает. В других случаях острое состояние постепенно сменяется астеническим синдромом.

При отравлении свинцом влияние на психику обнаруживается лишь после длительной интоксикации. В легких случаях заболевание ограничивается астеническим синдромом, в более тяжелых развивается так называемая свинцовая энцефалопатия с нпилепти-формными припадками; иногда наблюдается делириозная спутанность.

Эрготизм («злая корча») вызывается ядами пищевого происхождения. **С и м п т о м ы**. После ряда предвестников (повышенная утомляемость, подавленное настроение, страхи и пр.) развивается состояние спутанности с галлюцинациями, иногда с резким возбуждением и аффектом страха или же ступор. В качестве остаточных явлений обнаруживаются неврологические симптомы; (отсутствие сухожильных рефлексов, симптом Ромберга и пр.; зрачковых симптомов не наблюдается), на основании которых иногда ставится диагноз табеса, по то время как налицо эргота-,новый псевдотабес.

**Т е ч е н и е**. Через 2—3 месяца, обычно наступает улучшение, заканчивающееся полным выздоровлением. Более тяжелые случаи заканчиваются смертью или же развивается хроническое состояние при наличии явлений слабоумия и эпилептиформных припадков. В течении болезни нередко отмечаются колебания — ремиссии и ухудшения.

**Л е ч е н и е** интоксикационных психозов. Вначале симптоматическое и согласно психопатологическому синдрому. На первом месте при отравлениях стоят профилактические санитарно-гигиенические мероприятия.

При эйфорическо-атактическом синдроме рекомендуются теплые ванны, внутривенное вливание " АЯ (25%) сернокислой магнезии, 10 мл (40%) глюкозы, 4 мл витамина Й» и 3 мл аскорбиновой кислоты. При психомоторном возбуждении и: 10 мл (10%) раствора гексепала внутримышечно в область ягодицы: если возбуждение очень резкое, то вслед за этим вводят 50 мг (2%) раствора медифала ректально, а также делают теплую ванну. При астеническом состоянии, наряду с усиленным питанием, рекомендуются малые дозы инсулина с последующим приемом (через 1—2 часа) 50,0—100,0 сахара, витамины А и С, люминал 0,1—0,2 па ночь. При психозах, протекающих при наличии резкого психомоторного возбуждения, резкого истощения, выраженной сердечной декомпенсации, резкой одышки и выраженной болезни печени, пользоваться морфином надо крайне осторожно, так как этот препарат увеличивает внутричерепное давление. В этих случаях целесообразнее прибегнуть к барбитуратам. При отравлении ТЭС противопоказан бром.

Хороший терапевтический эффект, полученный в результате применения длительного сна у животных с различными интоксикациями и инфекциями (А. Г. Иванов-Смоленский), открывает широкие перспективы для применения этого метода при интоксикациях и инфекциях у человека.

**ИНФЕКЦИОННЫЕ ПСИХОЗЫ.** Иадо различать психозы иа вочве острых и хронических инфекций.

**Острые инфекционные психозы. С и м и т о м ы.** Инфекционные психозы проявляются в виде так называемого инфекционного делирия и аментипного синдрома. При инфекционном делирии вначале отмечается общее недомогание, головные боли, повышенная чувствительность к внешним раздражениям, раздражительность, затруднения в мышлении, расстройство сна, кошмарные сновидения. Постепенно становится более выраженным расстройство сознания, появляются галлюцинации, бред, в образовании которого большую роль играют неприятные ощущения в различных органах. В даль\* аейшем может наблюдаться состояние тяжелого оглушения. Амен» гг.впый синдром характеризуется развитием спутанности, сопровождается бредом, галлюцинациями, иллюзиями и двигательным возбуждением. Болезнь начинается бессонницей, беспокойством, растерянностью, все, окружающее кажется изменившимся, странным. Реже выявляется астено-абулический синдром (см. *Синдромы, Добавление II*).

Аментивный синдром более длительное заболевание, чем инфекционные делирии.

**Р а с п о з н а в а н и е** требует отграничения от шизофрении. Наличие внешней вредности, благоприятное течение и исход в выздоровление при отсутствии стойких шизофренических симптомов позволяют отграничить аменцию от шизофрении.

Всякое тяжелое инфекционное заболевание оставляет после себя — на более или менее короткий срок — известные психические изменения. В основном различают: состояние посленпфекционной психической слабости (астения) и амиестический (Корсаковекпи) синдром. \*

**Состояние/ посленпфекционной психической слабости** выражается в резкой утомляемости, повышенной чувствительности к внешним раздражителям, эмоциональной лабильности, ослаблении памяти и внимания, пониженом питании и пр.

**К о р с а к о в с к и й с и н д р о м** характеризуется резким расстройством запоминания, конфабуляциями, нарушениями главным образом ориентировки во времени, обычно вялостью.

**Т е ч е н и е.** Длительность заболевания от недели до месяцев.

**Особенности исихозов прп различных острых и н ф е к ц и я х** (см. также *Синдромы, Добавление II*)

**Бешенство. С и м и т о м ы.** Болезнь начинается через 2—10 недель (а иногда значительно позднее — через год и более) после (яражения — укуса бешеным животным и проявляется сильной головной болью, болезненным беспокойством и подавленностью, переходящими в повышенную чувствительность к внешним раздра-

жения.м. По мере повышения температуры появляются характерные спазмы при глотании, приступы удушья, сухость во рту, сильная жажда. Больные приходят в состояние резкого возбуждения с галлюцинациями, бредом, аффектом страха, неистово кричат. Сознание постепенно начинает помрачаться, появляется долприоз-нос состояние и спутанность, сопровождающиеся вначале возбуждением, а затем наступают параличи главным образом ног, судороги, расстройство речи. В таком состоянии больные погибают через несколько дней после начала острых явлений. В отдельных случаях наблюдается сложное бешенство» с психическим истерическим синдромом.

**Бруцеллез. С и м п т о м ы.** На высоте температуры — делириозное состояние, реже апатия, некоторая оглушенность па фоне визуальной депрессии. Наблюдается также бред отношения, кататоноподобные картины.

**Брюшной тиф. С и м п т о м ы.** Психические расстройства реже, чем при сыпном тифе. В лихорадочном периоде — делирии, после падения температуры — энлеитиформное возбуждение и сумеречное состояние. Нередкб отмечается эйфория с бредом величия. В заключительном периоде возникает иногда амнестический и астенический синдром.

**Воспаление легких. С и м п т о м ы.** Проявляется в виде бурного лихорадочного бреда, астенического, депрессивного, реже делириозно-аментивного п депрессивно-параноидного синдрома.

**Грипп. С и м п т о м ы.** Реже встречаются инфекционные делирии, чаще аментивный синдром и астено-абулическое состояние с ипохондрически-параноидными установками, страхом.

**Малярия. С и м п т о м ы.** Наблюдаются делириозные эпизоды, галлюцинаторный бред, эпилептиформные состояния возбуждения, острая спутанность. Иногда отмечается развитие корсаковского синдрома, хронические изменения характера и стойкое слабоумие на ночь малярийного менинго-энцефалита. В случаях хронической малярийной кахексии наблюдаются состояния депрессии, астении, аментивный синдром.

**Оспа. С и м п т о м ы.** Эпилептиформное возбуждение, сменяющееся аментивным состоянием. Впоследствии нередко стойкие изменения характера с склонностью к аффективным вспышкам.

**Пиемические и сеитицемические процессы** (в связи со злокачественными ангинами, гангреней легких и пр.). **С п м и т о м ы.** Оглушенность, делириозные состояния с резким возбундиписм вначале. \*

**Рожа головы. С и м п т о м ы.** Часто дает осложнение в виде делириозного состояния, иногда эпилептиформные припадки.

**Сыпной тиф. С и м п т о м ы.** Психические изменения наблюдаются часто в резко выражены. В начале болезни нередко гино-маниакальные состояния, затем пышный бред со сложными переживаниями, яркие галлюцинации, отмечают также апато-абущеческие и астено-адипамнческе синдромы, которые нередко заканчиваются аментивным синдромом.

**Суставной ревматизм. С и м н т о м ы.** В школьном периоде энлеитиформное возбуждение и кратковременное сумеречное

состояние. После падения температуры иногда развивается аменитивный синдром, иногда же ступор, сменяющийся возбуждением, сонливость. При склонности ревматизма к затяжному течению — более длительное психическое расстройство с нарушениями эффективности, снижением памяти и интеллекта и повышенной истощаемостью. Особенно характерны психосензорные расстройства\*.

**Лечение острых психических заболеваний.** Прежде всего следует обратить особое внимание на лечение основного заболевания, для чего необходимо прибегнуть к консультации врача-терапевта, специалиста по инфекционным заболеваниям.

Лечение сводится прежде всего к заботе об общем соматическом состоянии больного (сердце!) и поднятию питания. Наряду с покоем и постельным содержанием, назначают клизмы из глюкозы (50%) или хлористого натрия (0,85%) по 50,0 мл с добавлением куриного белка, овощного или рисового отвара, непродолжительные холодные обтирания, вазелины, бромиды, снотворные. В тяжелых случаях требуется неустанный надзор. Надо оберегать больного от пролежней.

В дальнейшем — при наличии воспалительных и токсических процессов — дезинтоксикационная и антисептическая терапия. В остальном лечение согласно соответствующим психопатологическим синдромам.

При выходе в астенический синдром большое значение имеют общеукрепляющие средства (фитин, липоцеребрин и пр.), а также общее облучение кварцем. После выздоровления — длительный отдых.

Необходимо отметить, что лечение бешенства пока совершенно недостаточно; единственной мерой против этой болезни являются профилактические пастеровские прививки, которые следует производить всем укушенным и подозрительным на укус животных и притом как можно скорее. Необходимо строго упорядоченное содержание домашних животных, уничтожение бродячих собак (главного источника заразы) и широкое осведомление населения о сущности бешенства и мерах предупреждения в виде своевременного производства прививок' (см. „ГЛ. II Инфекционные болезни. Бешенство“).

**ИНФЕКЦИОННЫЕ ПСИХОЗЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ** — см. *Прогрессивный паралич, Сифилис мозга, Энцефалит эпидемический и пр.*

**Туберкулез. Симптомы.** Раздражительность, быстрая утомляемость, неустойчивость настроения, состояние депрессии, апатии. В последней стадии легочного туберкулеза наблюдается нередко эйфория. В редких случаях имеет место аменитивный синдром, иногда астенический, депрессивный, еще реже — депрессивно-аменитивный, депрессивно-параноидный синдром.

**ИСТЕРИЯ. Этиология и патогенез.** В основе — общая слабость нервной системы в соединении с погранично-шизофренической сигнальной системой, причем особенно слабой оказывается вторая сигнальная система. Под влиянием незначительных для такой слабой нервной системы внешних раздражений нарушаются правильные взаимоотношения между корковой и подкорковой деятельностью в направлении усиления последней (Г. П. Павлов).

Это обстоятельство, а также положительная индукция с коры, легко падающей в торможение, ведут к усилению деятельности подкорки. Характерным для истерии является склонность к возникновению гипнотических фаз, промежуточных состояний между бодрствованием и сном, предпосылкой для которых является высокая тормозимость коры, обусловленная ее слабостью. Повышенная эмоциональность, склонность к действиям под влиянием аффекта, а также возникновение примитивных судорожных припадков связаны с усилением деятельности подкорковых образований (И. П. Павлов). Те пункты коры, которые под влиянием эмоции «заряжаются из подкорки», ясно, приобретают перевес над другими очагами возбуждения и путем сильной отрицательной индукции ясно подавляют все конкурирующие очаги возбуждения. Повышенная внушаемость и самовнушаемость обусловлена возникновением гипнотических фаз. Раздражители обычной силы при относительной слабости коры становятся сверхъестественными, в связи с чем чаще возникает гипноидное состояние. Склонность к необузданному фантазированию, вымыслам объясняется слабостью второй сигнальной системы, которая детка приходит в торгизмозное состояние и высвобождает из-под своего контроля первую сигнальную систему. В результате — оживление первой сигнальной системы с ее образностью и конкретностью.

**Симптомы.** В основе истерического характера лежит повышенная эмоциональность, повышенная внушаемость и самовнушаемость, эгоизм и эгоцентризм, стремление к преувеличению и фантазированию, склонность к аффективным разрядам, частые смены настроения. Указанные симптомы могут усиливаться, а также возникать под влиянием внешних факторов, травмирующих психику (тяжелые переживания, физические травмы, алкоголь, инфекции).

Истерические проявления выражаются также в виде истерических судорожных припадков, связанных с эмоциональными переживаниями, сумеречных состояний сознания с психологически понятным содержанием (в отличие от эпилептических сумеречных состояний), в двигательных расстройствах (парезы, параличи, астазия — абазия), расстройствах со стороны речи (афония, заикание и пр.), понижении или отсутствии рефлексов со стороны слизистых, болезненных ощущениях в различных частях тела, ощущениях клубка в горле, изменениях чувствительности (понижение или повышение), расстройствах со стороны зрения (полная или частичная слепота), громком плаче, переходящем в смех, и т. д. Все эти симптомы наблюдаются на фоне значительно нарушенной вегетативной реактивности. Решающим для диагноза является отсутствие органических симптомов в нервной системе. Следует, впрочем, иметь в виду, что за истерическими симптомами иногда скрывается органическое поражение центральной нервной системы.

Истерические симптомы могут усиливаться при нахождении больного в условиях, соответствующих первоначальному их появлению, чем подчеркивается условнорефлекторная природа таких истерических стигм, как расстройство чувствительности, слепота и пр. Возможность вызывания или прекращения припадков при истерии путем давления на определенные пункты тела, зоны тоже

содержит элементы умовнорефлекторного и суггестивного воздействия.

Т с ч е и е разнообразное: в одних случаях отмечается быстрая смена многочисленных симптомов, в других — проявления болезни более однообразны.

Л е ч е н и е. В основном лечение сводится к изменению тех жизненных условий, которые способствовали возникновению заболевания. Большое значение имеет правильный трудовой и бытовой режим, а также рациональное воспитание (психотерапия). Нужно осторожно проводить психотерапию, выявлять болезненные переживания, нарушающие психические функции, уделять внимание половому фактору. При этом не следует заострять внимание больного на тягостных переживаниях — во избежание закрепления или дальнейшего развития болезненных явлений. На припадки, приступы возбуждения лучше всего не обращать внимания, либо купировать их, опираясь на врачебный авторитет, т. е. простым внушением, не прибегая к гипнозу. Большое значение имеет трудовая терапия, отвлекающая больного от его переживаний и создающая условия для здорового общения с коллективом. В случае более резких проявлений истерических психозов необходимо<sup>1</sup> стационарное лечение и удаление больного из вредно действующей на него обстановки.

Из медикаментозных средств наиболее эффективны, по И. П. Павлову и М. К. Петровой, малые дозы брома, а также комбинация брома с кофеином. Бром в чистом виде усиливает тормозные процессы, а бром с кофеином ставит нарушенные процессы головного мозга в правильные соотношения между раздражительным и тормозным процессом. Широко пользуются удлиненным физиологическим сном.

Rp. Natrii bromati 0,5—2,0% 200,0 Coffeini  
natrio-benzoici 0,2—0,8 S. No 1 столовой  
ложке 3—4 раза в день

Для лечения истерических припадков с успехом применяют барбитураты (длительный сон в течение 3—4 дней). Все упомянутые мероприятия достигают цели в сочетании с психо- и трудотерапией, а также физкультурой.

При истерических параличах рекомендуется эфирный наркоз с предварительным введением 0,01 фенамина, при истерической афонии — внушение и суггестивная электризация (фарадизация шеи), при настойчивых убеждениях произнести какой-нибудь звук.

Из физиотерапевтических мероприятий рекомендуются: а) сильный фарадический ток, б) искры статической машины, в) огненные пучки д'арсовалл всех токов.

МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ. Этиологические факторы недостаточно выяснены. И. П. Павлов подчеркивает этиологическое значение внешних факторов. «Циркулярность» Павлов объясняет как следствие нарушения взаимоотношений между процессами возбуждения и торможения. Наиболее благоприятной почвой для возникновения маниакально-депрессивного психоза является, по Павлову, повышенная возбудимость нервной системы. В этих условиях «нет соответствующего умеряющего и востанав-

ливающего процесса, процесса торможения, раздражительный процесс переходит за пределы работоспособности клеток больших полушарий». Ничем не сдерживаемое возбуждение ведет к перенапряжению, так что нервная система «расплачивается» тут же периодами депрессии. Этим при гипоманиакальных состояниях обуславливаются нарушения правильной смены нормальной работы с нормальным отдыхом. Здесь наблюдается ослабление как внутреннего, так и внешнего торможения, т. е. явное преобладание раздражительного процесса над тормозным в отношении простейших форм условно-рефлекторной деятельности. Вместе с тем более сложные формы этой деятельности оказываются заторможенными. При депрессивной фазе имеется преобладание тормозного процесса над раздражительным, относительная слабость раздражительных процессов в коре головного мозга (Фаддеева). Ослабление процессов внутреннего торможения соответствует характеру депрессивного бреда, который И. П. Павлов назвал «бредом чувства», и его возникновение объясняется ослаблением тормозного процесса.

Депрессивная фаза иногда выражается в тоске, тревоге, страхах с двигательным беспокойством, представляющим в отдельных случаях большую опасность в смысле нанесения себе повреждений попыток па самоубийство.

При ажитированной депрессии соотношение раздражительного и тормозного процесса изменяется следующим образом: при корковой пассивно-оборонительной доминанте, обусловленной очагом застойного возбуждения, одновременно возникает отрицательная индукция на все другие функции корковой и подкорковой области (Иванов-Смоленский).

Известную роль играют эндокринно-вегетативные нарушения, связанные с изменениями в коре и в области подкорковых образований, что отчасти объясняет периодическое течение психоза.

С и м п т о м ы. Болезнь протекает в виде приступов (маниакальные, депрессивные или смешанные маниакально-депрессивные фазы), между которыми отмечаются светлые промежутки, когда больной клинически здоров. Симптомы маниакальной фазы: повышенное настроение, интеллектуальное и психомоторное возбуждение (скачка идей, но без разорванности, отвлекаемость, стремление к непрерывной деятельности, резкое возбуждение, отсутствие чувства усталости). Наряду с этим, имеет место переоценка собственной личности, иногда бредовые идеи (идея величия). Симптомы депрессивной фазы: угнетенное настроение, интеллектуальная и психическая заторможенность, бредовые идеи самообвинения, преследования, стремление к самоубийству. Со стороны соматики — падение веса (в обеих фазах).

При депрессивной фазе очень характерны так называемые суточные колебания сна: по утрам больные чувствуют себя хуже, чем вечером. Маниакальные больные могут в течение длительного периода почти не спать, так как они не испытывают потребности в сне. Аппетит у них повышен, в то время как у больных, находящихся в состоянии депрессии, понижен; часто отмечаются запоры. Пульс нередко повышен при обеих фазах. Как при депрессивной так и маниакальной фазе имеются нарушения обмена веществ

**Лечение.** При депрессивной фазе большое значение имеет Психотерапевтический контакт с больным. При выходе из депрессии очень важно строгое соблюдение больным режима дня, дозированной трудовой терапии. Больные должны много времени проводить *III* в воздухе. В случае более легкой депрессии рекомендуется: валериановые препараты в виде капель или инфуза, введение через день кислорода (200—400 см<sup>3</sup> подкожно), переливание 200—300 мл крови, теплые углекислые, а на утроем холодные ванны и массаж кожи.

При более тяжелом состоянии депрессии рекомендуется комбинированная терапия (инсулиновая гипогликемия -/- терапия сном) или изрядней прерывистый сон, а также опий.

Ер. T-rae Opii simplicis 20,0

DS. Начать с 6 капель 3 раза в день, добавлять каждый день по 3 капли на прием, доводя до 3 раз в день по 20 капель

На этой дозе больной остается в течение 2 недель. Затем: дозу постепенно, по одной капле в день, убавляют. Если депрессия начинает идти на убыль, курс можно сократить, не доводя его до максимальных доз.

Если опий вызывает запоры и падение, аппетита, следует прибегнуть к водному экстракту опия или подкожным впрыскиваниям.

Хорошее действие оказывает гидротерапия.

Из физиотерапевтических мероприятий при депрессивной фазе рекомендуется: а) общее облучение ультрафиолетовыми лучами; б) теплые ванны (желательно углекислые) длительностью 20—30 минут; в) общая дарсонвализация; г) статический дуг (главным образом при плохом сие). Полезна также рентгенотерапия — 2 или 3 сеанса облучения области турецкого седла очень малыми дозами.

При маниакальном состоянии из общих мероприятий рекомендуется длительное пребывание на воздухе, желательное с направлением активности больного на какую-либо деятельность, усиленное питание, богатая углеводами пища. Из лекарств\* при легкой степени возбуждения рекомендуется адалин (0,5 мл 3—4 раза в день), при более выраженных степенях возбуждения — барбитураты. При резких степенях возбуждения (см. также *Возбуждение*) рекомендуется клизма из хлоралгидрата.

Ер. Chlorali hydrati

Mucilaginis Amyli 1,0

Aq. destill. aa 15,0

MDS. На 1 клизму (вводить медленно!)

Эффективно лечение новокаиновой блокадой по Вишневскому (В. И. Протопопов).

**МОРФИНИЗМ.** *Этиология и патогенез.* Возникает на почве хронического отравления морфином. Привыкание зависит от увеличенной способности организма, особенно мозговой ткани, разлагать этот яд; способность связывать морфин все нарастает, чем *II* объясняется привыкание протоплазмы нервной ткани к яду.

Морфинизм в СССР за последние десятилетия встречается очень редко, в единичных случаях.

**Симптомы.** Смена настроения, расстройство памяти, внимания, снижение работоспособности, изменение характера в сторону большей замкнутости, моральные изъязнения, расстройство сна, нарушение питания. Явления воздержания от морфина, которые проявляются через несколько часов после прекращения приема, выражаются в мучительном беспокойстве, резкой усталости, чихании, зевоте, зябкости, потливости, болезненных нарастаниях, подергиваниях, расстройстве кишечника, головокружениях, обмороках.

**Лечение.** Проводится в закрытом лечебном учреждении. От больных следует брать расписку в том, что они могут быть задержаны против их воли. Целесообразно в первое время не давать свиданий. Отнимать морфин следует, как правило, сразу, но при резко выраженных болезненных явлениях в результате полного воздержания рекомендуется давать в течение 1—2 дней морфин; при постепенном отнятии начинают с половины той дозы, до которой дошел больной (размер этой дозы больные обычно преувеличивают) и в течение 5—10 дней доводят ее до нуля.

При воздержании от морфина наблюдаются выраженные явления охранительного торможения, на фоне которого отмечаются фазовые состояния. Этим объясняется, что длительны: лечебный сон (от 5 до 10 суток) предупреждает тяжёлые осложнения, наблюдающиеся в периоде воздержания.

После периода дезинтоксикации назначают трудовую терапию, физкультуру, проводят культурно-просветительные мероприятия. Полезно пребывание на свежем воздухе. Целесообразна психотерапия — внушение наяву.

**НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВОСТИ** см. *Психастения*.

**ОЛИГОФРЕНИЯ.** *Этиология и патогенез.* Задержка развития плода в связи с перенесенной инфекцией, интоксикацией, травмой, а также в связи с выраженными эндокринными нарушениями.

**Симптомы.** На фоне общего недоразвития всего организма выступает более или менее резко выраженное недоразвитие психики, прежде всего умственной сферы, в зависимости от степени слабоумия, различают идиотию, имбецильность и дебильность<sup>1</sup>. Со стороны соматике часты аномалии строения и формы отдельных частей, объединяемые под названием дегенеративных признаков (волчья пасть, заячья губа, полидактилия), недоразвитие двигательных функций, недостаточность речи.

**Лечение.** Медикаментозное и хирургическое лечение начинается в зависимости от характера соматических расстройств (пункция — при резко повышенном нарушении внутричерепного давления; эндокринные препараты — при выраженной эндокринной недостаточности). Больные с тяжелой степенью недоразвития

<sup>1</sup> Имбецильность — менее глубокая (сравнительно с идиотией) степень олигофрении.

Дебильность — наиболее легкая степень умственной отсталости, которая может быть компенсирована воспитательно-учебными УСЛОВИЯМИ.

нуждаются и социальном признании. Страдающие олигофренией в степени дебильности обучаются в специальных школах. Основная задача — последующее трудоустройство в соответствующих их возможностям условиях.

**ПРОГРЕССИВНЫЙ ПАРАЛИЧ. Э т и о л о г и я и п а т о г е н е з .** Сифилис в анамнезе. Полной ясности в оценке значения добавочных факторов не имеется.

За последние годы, благодаря широким профилактическим мероприятиям и своевременному лечению сифилиса, проводимым в < оветском Союзе, случаи прогрессивного паралича резко уменьшились.

Дефекты поведения больных прогрессивным параличом свидетельствуют о нарушении правильных соотношений между первой и второй сигнальной системой (И. П. Павлов). Первая сигнальная система действует, а сложные комплексы второй сигнальной системы, т. е. более общие понятия, нарушены. Расстройство деятельности второй сигнальной системы выражается в нарушении общих понятий, причинности, времени, пространства. Больной не вникает в смысл противоречий, допускает невероятные, несуразные связи явлений. Наряду с нарушением соотношения между первой и второй сигнальной системой, у больного имеются глубокие нарушения процессов возбуждения и торможения. Эти нарушения сказываются в особой инертности и застойности процессов торможения, которые развертываются на фоне резко выраженной ареактивности мозга.

**С и м п т о м ы .** Болезнь чаще всего проявляется в возрасте 35—50 лет неопределенными неврастеническими жалобами; важно во всех подобных случаях произвести исследование крови и спинномозговой жидкости на реакцию Вассермана. В развернутой стадии наблюдаются симптомы нарастающего слабоумия, резкое расстройство памяти, способности запоминания, счета, внимания. В эмоционально-пальпой сфере нередко отмечается эйфория (благодушное, воз|уж|Деп-ное настроение). Отмечается известная степень изменения сознания: больной живет как бы во сне или в состоянии легкого опьянения. Нередко наблюдается бред; особенно характерен вред величия. Отмечаются зрачковые расстройства: неправильная форма зрачков, аннзкория (неравномерность), миоз (сужение), вялость или отсутствие реакции зрачков на свет при сохранении реакции на аккомодацию. Расстройства речи (невнятная, спотыкающаяся на слогах), письма (пропуски слогов), маскообразное лицо, беспокойная иннервация вокруг рта, понижение чувствительности (гппалгезии). Резко положительная реакция Вассермана в крови и спинномозговой жидкости.

**Л е ч е н и е .** Основным методом лечения является прививка трехдневной малярии и лечение пенициллином в стационарных условиях.

**ПСИХАСТЕНИЯ. Э т и о л о г и я и п а т о г е н е з .** Способствующими моментами являются внешние факторы. Начало болезни часто бывает связано с соматическим и психическим истощением и травмами.

И. П. Павлов отделяет навязчивые состояния как расстройства, имеющие в своей основе определенные очаги патологической инерт-

пости (см. *Дополнение J*) и могущие развиваться у лиц с различным типом нервной системы, от психастении как особого склада личности. Личность страдающего психастенией характеризуется резким преобладанием корковой деятельности над подкорковой и неуравновешенностью обеих сигнальных систем, выражающейся в болезненном преобладании второй при относительной слабости первой сигнальной системы. Отсюда отсутствие чувства реального, склонность к умственной «жвачке», к бесплодному и искаженному умствованию в виде навязчивых идей, страхов и пр.

В основе навязчивых явлений, но И. П. Павлову, лежат два патофизиологических механизма. Для нормальной нервной системы характерна легкость перехода от состояния возбуждения к состоянию торможения и обратно, способность легко создавать временные функциональные структуры, в то время как при явлениях навязчивости наблюдается тенденция задерживаться, «застрывать» на определенных состояниях. Это так называемая патологическая инертность возбуждения или торможения. Школа И. П. Павлова дает также физиологическое объяснение того факта, что больные вне своих навязчивых идей, сконцентрированных вокруг определенных вопросов или событий, могут вести себя правильно. Это объясняется открытым И. П. Павловым законом «системности» явлений, протекающих в центральной нервной системе. Процессы могут ограничиться определенными участками мозга, а остальные участки не обнаруживают функциональных расстройств. Это так называемый изолированный больной пункт. Состояния неправильного реагирования на внешние раздражители и состояния патологической инертности могут охватывать отдельные очаги, не затрагивая мозга в целом. При этом речь идет не о топографически ограниченных очагах, а об очагах, которые представляют собой единую физиологическую систему. Таким образом, Павлов понимает психастению шире, чем навязчивость.

**С и м п т о м ы .** В психической картине доминируют навязчивые представления (болезненные сомнения, болезненное мудрствование), навязчивые действия (навязчивый счет и т. П.), навязчивые страхи (боязнь заболеть сифилисом, боязнь острых предметов и пр.).

**П р о ф и л а к т и к а** особенно важна в детстве, как только обнаруживаются черты психастенического характера (нерешительность, тревожность). Большое значение имеет всемерное вовлечение ребенка в коллектив, активирование спортом, физкультурой, обучение ремесла\*!.

**Л е ч е н и е .** Важно подчеркнуть применение гипноза при неврозе навязчивости и почти полную его безэффективность при психастении. Задача рациональной психотерапии сводится к воспитанию воли, при этом показан строгий трудовой режим. Длительный отдых может принести вред. В целях преодоления навязчивых идей уместны рациональные отвлечения — спорт, путешествия. Важно добиться того, чтобы «жизнедеятельность больного, не смотря на наличие этих болезненных проявлений, существенно не страдала.

Из медикаментозных средств рекомендуется: Пр.  
Sol. Galicini chlorati 10% 30,0 D. t. d. N. 5 in  
amp. S. По 2 мл внутривенно

В острых случаях рекомендуется: Кр. Natrii  
bromati 5,0 G hi cos i 0,5 Af. dcstill.  
50,0 Steriliscutur! DS. Для подкожного  
введения

Из физиотерапевтических мероприятий: а) дарсонвализация (при фобиях); б) статический душ (при головных болях и бессоннице); в) теплые ванны.

**ПСИХОЗЫ РЕАКТИВНЫЕ (ПСИХОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ).** Этиология и патогенез. При реактивных депрессиях ясно выражена тенденция к появлению состояний, промежуточных МШДУ бодрствованием и сном. Факторами, усиливающими тормозное состояние коры головного мозга больных реактивной депрессией, на фоне чего возникают фазовые явления, могут быть: небольшое утомление, требование хотя бы незначительной переадаптации корковой деятельности или отрицательные эмоциональные реакции, связанные с патодинамической структурой коры головного мозга больного. Явления патологического торможения во второй сигнальной системе выражены резче, чем в первой.

**Г, т, г, п, т, о, м, ы.** Всегда обратимые болезненные состояния, которые непосредственно зависят от травмирующего действия на психику ряда тяжелых переживаний, связанных с условиями жизни. В основном различают: реактивные депрессии (подавленное настроение, тревога, безволие при вполне сохраненной интеллектуальной деятельности), параноидные реакции (бредовое толкование окружающего, понятным образом связанное с травмирующими переживаниями) и истерические реакции (см. *Истерия*).

**Лечение** состоит прежде всего в устранении травмирующих моментов. Наиболее активным методом является психотерапия, которая требует большой индивидуализации. Здесь применяют все виды психотерапии, вплоть до гипноза. В острых случаях больные подлежат помещению в стационар. При реактивной депрессии рекомендуется:

" В р. Extr. Opil 2,0  
Pulv. et Extr. rad. Rhei aquosi  
q.s. ut fiat pil. N. 100  
DS. По 3—5 пилюль в день

Ясно выраженная тенденция к возникновению фазовых состояний свидетельствует о целесообразности при реактивных депрессиях и депрессивно-параноидных состояниях искусственного углубления охранительного торможения путем применения снотворной терапии; при преобладании параноидного<sup>TM</sup> весьма уместно сочетание шюулиновой гипогликемии и терапии сном.

a\*

**ПСИХОЗЫ СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ).** Алшеитарная дистрофия. С и м п т о м ы. Психические расстройства чаще всего в виде делирия или аменции или же в виде апато-абулического состояния, нередко закапчивающиеся астеническим синдромом. Чаще, чем психозы, наблюдаются изменения характера в виде расторможения влечений. Все это встречается при наличии дополнительных раздражающих факторов — физических (особенно холод) и патологических.

**Лечение** должно быть прежде всего направлено и сторону основного страдания. Пища должна быть более богата белками и жирами, чем углеводами. Требуется абсолютный покой, из лекарств назначают фосфор, фитин, 40% глюкозу (15 мл внутривенно через день). Наряду с этим, переливание крови (100—200 мл), применение сухой плазмы, инсулин (2—6 единиц подкожно натошак через 2—3 часа), затем 50% сахара, общее облучение кварцем, диатермия головы. В остальном — лечение согласно психопатологическому синдрому.

Авитаминозы и гипоавитагавозы. С и м п т о м ы. Преобладающим синдромом является аментивия, дслириозный, астенический, депрессивный и депрессивно-параноидный. Почти как правило — выход в астению.

**Лечение** согласно психопатологическому- синдрому и, в зависимости от авитаминоза, назначение соответствующих витаминов.

**ПСИХОЗЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ПОЧВЕ БОЛЕЗНЕЙ ВЛУТ-ГЕШНХ ОРГАНОВ И ОБЩИХ ЗАБОЛЕВАНИИ.**

а) Болезни еердца. С и м п т о м ы. Самым частым симптомом являются тревожно-депрессивные реакции, сопровождающиеся чувством беспредметной тоски, страха смерти, резкого возбуждения. В ряде случаев наблюдаются делириозные состояния со спутанностью, возбуждением, чувством страха, галлюцинациями (чаще зрительными), с тревожно-боязливым настроением, бессонницей.

**Лечение.** Устранение нарушений циркуляции кроен (сердечные и диуретические средства), а также лечение согласи», психопатологическому синдрому.

б) Болезни ?желудочно-кишечного тратта. С и м п т о м ы. Расстройство желудочно-кишечного тракта ведет в отдельных случаях к психическим реакциям., в тяжелых случаях к депрессивно-параноидным (нередко затяжным) состояниям с выходом в астению.

**Лечение.** Наряду с лечением, согласно психопатологическому синдрому, рекомендуется симптоматическое лечение, (адалин, бром).

в) Болезни печени. С и м п т о м ы. Острая желтая атрофия печени нередко сопровождается дслириозным или амсптив.ім синдромом, а желтуха с холециститом (тяжелые формы) — иной да апато-абулическим синдромом, сумеречным состоянием, шшлемиформными судорогами.

**Лечение** и е желчегонными и мочегонными средствами, и остальное — согласно психопатологическому синдрому.



г) Болезни ночек. С и м п т о м ы. Острая уремия, сопровождающаяся в отдельных случаях делириозным или аментивным синдромом, эпилептиформными припадками, кататоническими явлениями.

Л е ч е н и е. В целях усиления деятельности почек и торможения процессов брожения в крови — теобромин и диуретин, а в остальном — лечение согласно психопатологическому синдрому.

д) Пернициозная анемия. С в и т о м и. В легких случаях наблюдаются депрессивные явления, в более тяжелых — делириозный, аментивный, тревожно-депрессивный и параноидный синдром:

Л е ч е н и е согласно основной болезни психопатологическому синдрому.

е) Рак. С и м п т о м ы. Наблюдается делириозный, аментивный, ступорозный синдром.

Л е ч е н и е согласно психопатологическому синдрому.

ж) Токсикозы беременности, послеродовые психозы. С и м п т о м ы. Токсикозы беременности отличаются депрессивным и ипохондрическим синдромом. При послеродовых психозах наблюдается острая галлюциаторная спутанность, в отдельных случаях — шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и истерия, для развития которых послеродовой период послужил только толчком.

Л е ч е н и е. Наряду с лечением дезинтоксикационными средствами, проводится лечение основного психопатологического синдрома.

**ПСИХОЗЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ВНЕЧЕРЕПНЫМИ РАНЕНИЯМИ, ОСТЕОМИЕЛИТОМ.** С и м п т о м ы. Чаще всего наблюдается галлюциаторно-параноидный и депрессивно-параноидный синдром, реже — эйфорический синдром, еще реже — ипохондрический. Выход часто в астенический синдром.

Л е ч е н и е. Наряду с лечением основного раневого поражения местным хирургическим вмешательством, применяется медикаментозное лечение в соответствии с разными этапами заболевания. В первом периоде заболевания применяют глюкозу, физиологический раствор поваренной соли, в дальнейшем — уротропин, стрептоцид, проводят общеукрепляющую терапию.\*

При всех симптоматических психозах рекомендуется переливание крови (если нет противопоказаний — например, определенная стадия септического процесса).

Все виды терапии должны носить щадящий характер, и в арсенал лечебных мероприятий должны быть включены методы, создающие охранительное торможение, прежде всего терапия сном (см. *Травматические психозы*).

**ПСИХОЗЫ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ.** Этиология и патогенез. В основе травматических психозов лежат несложные и осложненные, открытые и закрытые травмы черепа, коммоции и контузии. К числу общих характерных нарушений, свойственных, как правило, всем стадиям болезни, относятся: расстройства крово- и ликворообращения, отек мозга, набухание его, повышение внутричерепного давления, вегетативные расстройства, состояния раздражения или, наоборот, адинамии.

В свежую стадию И. П. Павлова потерю сознания и оглушенность при коммоциях и контузиях мозга можно рассматривать как ре-

зультат наступающего экстренного торможения защитного характера. Дольше всего это торможение задерживается в функциональных структурах второй сигнальной системы, ярким примером чего является травматическая глухонмота, на первом этапе — слабость внутреннего торможения. При отдаленных же последствиях закрытых травм головного мозга отмечается сочетание этой слабости с исключительно выраженной патологической инертностью нервных процессов с превалированием процессов торможения. Клинически это выявляется в форме вялости, сонливости, апатии, истощения и пр.

При закрытых травмах черепа явно выступают нарушения нормальной подвижности как раздражительных, так и тормозных процессов, особенно при взаимодействии первой и второй сигнальной системы. Движение корковых процессов от первой сигнальной системы ко второй происходит обычно труднее, чем от второй к первой.

Среди других отклонений при закрытых травмах черепа наблюдаются проявляющиеся на тормозном фоне и быстро истощающиеся аффективные вспышки типа взрывчатости, а также повышенная реактивность. Больные резко реагируют на яркий свет, посторонние звуки, громкий разговор. Эти повышенные реакции на слабые раздражители можно объяснить нарушением здесь закона силы. Именно с этой точки зрения объясняется огромное количество жалоб у тех больных, у которых органические симптомы выражены весьма слабо или совсем отсутствуют, тогда как у больных с выраженными органическими симптомами жалоб обычно меньше.

С и м п т о м ы весьма разнообразны и находятся в зависимости от различных моментов: от формы поражения, его тяжести, распространенности и локализации, от времени, прошедшего после травмы, от различных осложнений, особенности личности. Следует учитывать начальный, острый и подострый, поздний и резидуальный период.

Л е ч е н и е зависит от стадии травматических поражений. В начальном периоде — абсолютный покой, постельный режим, лед на голову, опорожнение кишечника. Против явления отека и набухания мозга, а также гипертензии применяют дегидратационные средства: в первые недели — гипертонические растворы, особенно 40% раствор глюкозы (40—60 мл внутривенно), ежедневно, а в дальнейшем — лишь в случае, если давление спинномозговой жидкости превышает 350 мл водяного столба.

Яркая выраженность процессов охранительного торможения\* при травмах головного мозга, особенно в начальном периоде, сделала показанной сонную терапию главным образом в виде удлиненного сна, давшего хороший терапевтический эффект (А. Г. Иванов-Смоленский, Э. А. Асратян, А. О. Долгин).

В заключительной фазе этого периода, характеризующейся обычно явлениями эмоционально-гиперчувствительной слабости, когда отпала необходимость в постельном режиме, наиболее целесообразны психотерапия, трудовая терапия, физкультура. Медикаментозные средства направлены на снижение мозговой возбудимости (сернокислая магнезия) и поднятие общего тонуса (витамины В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и С,

мышьяк, железо); из физиотерапевтических средств назначают ванны и ионогальванизацию с хлористым кальцием.

• В острой и подострой стадии лечение" должно меняться в соответствии с доминирующим синдромом (делириозный и пр.). Лечение при поздней стадии в основном заключается в назначении гипертонических растворов, прежде всего 5% раствора сернокислой магнезии. Первоначальную дозу в 5 мл постепенно доводят до 10—15 мл; в среднем делают 10—15 вливаний, которые проводят в одно и то же время. Вводить магнезию надо осторожно, так как попадание ее под кожу может вызвать некроз (абсцесс), и медленнее (не больше 5 мл в минуту). Лечение отдаленных последствий травмы черепа зависит от особенностей нарушений. На первом этапе — гебуется успокаивающая терапия (покой, бромиды и пр.), на втором — укрепляющая, с постепенной нагрузкой физкультурой, спортом и трудовым режимом.

При тех синдромах, при которых ярко выражены явления охранительного торможения, положительные результаты дает углубленный сон (12—15 часов в сутки), чаще всего в течение 1—2 недель. На дальнейшей стадии лечения показано комбинирование снотворных и небольших доз стимулирующих средств (фенамин, кофеин и т. п.).

При осложненных травмах черепа наибольшее значение имеют сульфаниламидные препараты.

**СТУПОР (ОСТРЫЙ).** Этиология. Помимо шизофрении и тяжелой депрессии, ступор изредка наблюдается при реактивных и органических психозах (прогрессивный паралич).

**Симптомы.** Состояние неподвижности с расслаблением мускулатуры (большей частью при тяжелой меланхолии) или с ее напряжением (при кататонии). В случаях расслабления мускулатуры приподнятая рука больного падает, как мертвая, при напряжении же мускулатуры попытка изменить положение тела больного встречает нарастающее сопротивление. Ступор может внезапно смениться возбуждением (см. *Возбуждение, Добавление IV*). Течение — от нескольких часов до недель и месяцев. Лечение. Рекомендуется применение следующих препаратов:

Rp. Sol. Coffeini natrio-benzoici 2% 30,0  
Sterilisetur!

DS. По 3—5 мл подкожно

Через 10 минут делают клизму.

Rp. Sol. Barbamyl 1,5% 30,0

DS. На одну клизму (температура воды 36°) Барбамил противопоказан при заболевании печени и почек. В этих случаях рекомендуется физиологический раствор поваренной соли (300—500 мл), 30% ректификованный спирт внутривенно (30—40 мл), кислород подкожно (200—300 см<sup>3</sup>), а также хлористый кальций.

Rp. Calcii chlorati 10% 10,0 D. t. d. N. 5 in  
amp. S. По 10 мл внутривенно  
ежедневно

При затяжном ступоре показано внутривенное введение барбитурата (15%) в дозе до 5—8 мл.

При отказе от еды, нередко сопровождающем состояние ступора, назначают солевые клизмы (стакан теплого физиологического раствора хлористого натрия 32—33°, 1—2 раза в день после опорожняющей клизмы), внутривенно вводят 10—30 мл 10% раствора хлористого натрия с последующим назначением обильного питья с сахаром, витамином (главным образом витамином С), дают 5—10 единиц инсулина натощак. Спустя 2—3 дня через зонд или, что менее эффективно, путем клизмы вводят 1,5 л молока, 1—2 яйца, 10—15 г поваренной соли, витамины и сахар. Для усиления всасываемости прибавляют несколько капель йода. Для лучшего удержания клизмы добавляют 2—5 капель опия, предварительно сделав очистительную клизму. При появлении ацетона в моче назначают слабительные соли, клизму на физиологическом растворе. Каломель противопоказан (опасность стоматита!). Усиленно снабжают организм жидкостью. При отказе от пищи в течение 2—3 суток больного надо стационаризовать.

**СУМЕРЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ.** Этиология. Чаще всего наблюдается при эпилепсии, травмах и истерии.

**Симптомы.** Помрачение сознания, неясная ориентировка в окружающем, одностороннее восприятие лишь отдельных элементов из окружающего мира. Обманы чувств, преимущественно устрашающего содержания, главным образом галлюцинации слуха и зрения и бредовое толкование окружающего. Резкая аффективная напряженность. В движениях преобладают автоматизмы. По выходе из этого состояния больные не помнят, что с ними было.

**Течение.** Длительность от минут до нескольких дней, в редких случаях — недель. Начало и конец острые, заканчиваются обычно сном.

**Лечение.** Тщательный надзор, постельное содержание. Извлечение спинномозговой жидкости и назначение наркотических средств. Из лекарств рекомендуется:

Rp. Hexenali 1,0

D. t. d. N. 4 in amp.

S. Растворить содержимое ампулы в 10 мл свежеприготовленной дистиллированной воды. Вводить внутримышечно 10 мл с последующим вливанием хлористого кальция:

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 5,0 D.

t. d. N. 5 in amp. S. По 10 мл  
внутривенно

Наряду с этим назначают:

Rp. Sol. Natrii hyposulfurosi 15% 10,0

Sterilisetur! S. По 30 мл внутривенно

Если всего этого недостаточно, добавить:

Мед. справочник

Rp. Coffeini natrio-benzoici 10% 1,0 D. t.  
d. N. 10 in amp. S. По 1 мл  
подкожно

**ШИЗОФРЕНИЯ.** Этиология и патогенез не могут считаться вполне выясненными. В изучении патогенеза огромный вклад внесло учение И. П. Павлова. При шизофрении речь идет, по И. П. Павлову, прежде всего о слабости нервной системы, особенно о слабости корковых клеток. Эта слабость вызвана как наследственными, так и приобретенными факторами (токсическое действие и пр.). Слабая нервная система при встрече с трудностями «после непосильного возбуждения приходит в состояние истощения». Истощение же — один из главных физиологических импульсов к возникновению тормозного процесса как «охранительного процесса», предохраняющего нервную клетку от дальнейшего истощения и гибели. Торможение при шизофрении И. П. Павлов рассматривает, с одной стороны, как патологию, с другой — как охранительное, защитное явление. Касаясь кататонического ступора, И. П. Павлов говорит, «что, с одной стороны, подобное состояние — патология, та; как оно лишает пациента возможности нормальной деятельности, с другой — по существу самого механизма есть еще физиология, физиологическая мера, потому что оно предохраняет корковые клетки против угрожающего разрушения вследствие непосильной работы». Основная особенность шизофрении — повышенная тормозная способность коры головного мозга, сопровождающаяся различными явлениями растормаживания подкорковых образований. И. П. Павлов всегда подчеркивал защитный характер торможения, в связи с чем стал понятнее более благоприятный прогноз при кататонических формах шизофрении, при которых явления защитного торможения особенно выражены. Эта концепция легла в основу лечения длительным сном,\*при котором физиологический покой, достигнутый торможением, углубляется добавочным торможением, вызванным действием снотворных.

Ряд шизофренических симптомов обнаруживает «существенное сходство с явлениями гипноза, которые Павлов рассматривает как особые состояния, обусловленные большим или меньшим распространением торможения как в коре, так и в нижележащих отделах головного мозга. Шизофрения в известных вариациях и фазах действительно представляет собой «хронический гипноз», который Павлов понимает как «торможение в различных степенях распространенности и напряженности». Это торможение может достигнуть различной степени глубины, в зависимости от чего возникают различные гипнотические фазы, т. е. состояния, промежуточные между бодрствованием и сном. Эти фазы отличаются большим разнообразием в зависимости от большего или меньшего распространения торможения как по различным областям самих полушарий, так и по различным отделам головного мозга», с одной стороны, а с другой — «как степень интенсивности торможения в виде различной глубины торможения на одних и тех же местах». При развитии фазовых состояний торможение может сосредоточиваться на одних участках коры мозга и оставлять свободными все другие области. При полном тор-

можении двигательной области наблюдается к а т а т о н и ч е - с к и и с т у о р и, в зависимости от того, на какой уровень стволовой части мозга распространится торможение, ступору может сопутствовать каталепсия и пр. В некоторых случаях кататонического ступора с мутизмом наблюдаются явления парадоксальной фазы, когда больные не реагируют на обращенные к ним обычным голосом вопросы, а начинают отвечать, когда вопросы задаются топотом. Если гипнотическая фаза охватывает первую и вторую сигнальную систему, имеет место растормаживание подражательных рефлексов детского периода и обнаруживаются симптомы эхо-праксии и эхолалии. Явления стереотипии И. П. Павлов связывает с феноменом «патологической инертности» раздражительного процесса — в сфере движений, галлюцинации — в сфере восприятия, причем местные нарушения могут иметь место то в первой сигнальной системе — образные галлюцинации, то во второй сигнальной системе — «словесные» галлюцинации, то в обеих системах одновременно — сложные образно-словесные галлюцинации. Симптомы кататонического возбуждения И. П. Павлов связывает с «буйством, подкормки», расторможением подкорковой области в связи с глубоким торможением корковой области. Симптомы гебефренической дурашливости связаны с растормаживанием онтогенетически ранних функциональных уровней мозговой деятельности.

**Симптомы.** В одних случаях можно наблюдать все нарастающее психическое оскудение, без бреда и галлюцинации, и болезнь распознается лишь тогда, когда дефект в психической деятельности больного становится совершенно отчетливым. В других случаях отмечается своеобразная детскость, дурашливость, гримасничанье. В третьих случаях преобладают расстройства двигательной сферы: то полная неподвижность неделями, месяцами, годами, то внешне ничем не мотивированное возбуждение импульсов агрессивного характера; часто отмечается чередование ступора с возбуждением. Таким больным часто свойственен негативизм (противодействие всему, что от них требуется) или, наоборот, автоматическая подчиняемость, застывание в одной позе, повторение чужих слов и действий и т. д. У них нередко наблюдается повышенное слюноотделение, неопрятность при естественных отправлениях. При преобладании в картине болезни бредовых построений имеет место бред преследования, воздействие током, гипнозом; больным кажется, что о них говорят, над ними смеются. Бред часто сочетается с галлюцинациями, преимущественно слуха или обоняния. Наконец, в ряде случаев на первое место выступает особое внимание больного к ощущениям в своем теле, в своей голове. Больной жалуется на целый ряд своеобразных ощущений, причем мысли об этих ощущениях принимают часто навязчивый характер. Такие больные обычно находятся в подавленном настроении.

Из соматических нарушений определенное значение имеют расстройства вегетативной нервной системы, вазомоторные расстройства, расстройства секреторных функций (сальное лицо и пр.), эндокринные нарушения, в первую очередь половых желез. Имеется определенное нарушение обмена веществ: понижение окислительных процессов, изменение белкового обмена. Последнее дало

повод говорить об аминотоксикозе при шизофрении, что требует дальнейшего подтверждения. Из неврологических симптомов к наиболее часто встречающимся относятся аномалии зрачков, моторные явления (раздражения и выпадения отдельных мышечных функций), головные боли.

Течение разнообразно. В основном имеется два типа: либо процесс развивается остро, заканчиваясь в короткий срок ремиссией, в отдельных случаях с той или иной степенью дефекта, либо же процесс развивается вяло, хронически, настолько медленно, что трудно бывает установить начало заболевания. Хроническое течение может быть непрерывно прогрессирующим или же развиваться толчкообразными приступами (сдвигами), оставляющими после себя в отдельных случаях все более углубляющий дефект.

**Л е ч е н и е.** В основу лечения должна быть положена павловская концепция охранительного торможения. В связи с этим на первое место следует выдвинуть сонную терапию. Преобладающее; количество больных должно быть направлено в психиатрические учреждения, где им обеспечивается правильно построенный режим учреждения, своевременная активная терапия и уход. В амбулаторных условиях может проводиться симптоматическая терапия, витаминотерапия, лечение переливанием крови, физиотерапия.

**Л е ч е н и е д л и т е л ь н ы м с и о м.** Длительный непрерывный сон был впервые введен в клинику М. Я. Серс-йским, А. Г. Иваиовым-Смолонекм и В. П. Протопоповым. С этой целью применялась наркозная смесь, состоящая из комбинации так называемых корковых и подкорковых ядов. Относительно высокая токсичность длительного наркоза вызвала возражение со стороны многих авторов и в настоящее время не проводится.

Длительный прерывистый сон нашел себе широкое применение. Он вызывается преимущественно назначением барбитала внутрь или через клизму. Больной должен тщательно подготавливаться к этому виду терапии: обследуется терапевтом, подвергается всем необходимым исследованиям (клинические анализы мочи и крови, рентгенологические, а где возможно и биохимические исследования — содержание в крови белка, сахара, билирубина и пр.). В специальной палате создается благоприятная для сна обстановка: окна завешены светонепроницаемыми шторами, полы устланы ковриками, дорожками, дверь "обита" (для понижения звукопроницаемости), проведены добавочные иппесели для использования переносной лампы. Учитывая влияние однообразных раздражителей на торможение центральной нервной системы в палате, следует оборудовать звуковые, световые и тепловые мягкие сигналы. Такими раздражителями служат подражание падению дождевых капель на крышу, шум вентилятора, тикание маятника, зеленый фонарь, мигающий «светлячок» и т. д. При этом приходится учитывать индивидуальные особенности и привычки больных. Разовые дозы барбампла 0,4 — 0,5, суточные дозы не выше 1,0.

Длительный сон проводится обычно в течение 4—8 суток. В отдельных случаях применяют повторные курсы и комбинированную терапию: комбинация сна с инсулином, с судорожной терапией и пр.

И. П. Павлов и его школа указали путь к снижению снотворных доз путем выработки условного рефлекса на те или иные раздражители. Для этого используют индифферентные порошки. Кроме того, вырабатывается условный рефлекс на время принятия снотворного. Учет всех этих обстоятельств (соответствующей обстановки, выбора раздражителей и правильного режима) создает возможность проведения сна частично без наркотических средств, в частности, с применением гипноза.

В отдельных случаях применяют удлинённый ночной сон, который достигается путем назначения снотворных, соответствующего режима и гипнотического воздействия. Метод наименее сложен и рекомендуется прежде всего при заболеваниях и состояниях, противопоказанных для лечения прерывистым и непрерывным сном, или при неглубоких нервно-психических расстройствах. Удлинение физиологического сна вызывается приемом снотворных препаратов вечером, перед ужином и через 30 минут после ужина. При пробуждении ночью или рано утром дается снотворное в третий раз в той же дозе. Из препаратов рекомендуются так называемые стандартные единицы снотворных (по Асратяну):

|                      |      |                  |       |
|----------------------|------|------------------|-------|
| I. Уретан .....      | 1,0  | II. Уретан ..... | 1,0   |
| Веронал .....        | 0,25 | Веронал ....     | и, 25 |
| Бромистый натрий 0,2 |      | Бромистый пат-   |       |
| Цтрамидоц ....       | 0,05 | рий .....        | 0,2   |
|                      |      | Тенодші.....     | 0,01  |

п.ш барбамил по 0,1—0,2 с пирамидоном 0,2 или нембутал 0,1 спирмидоном 0,2. Курс лечения 15-30 дней с перерывом через каждые 5 дней на одни сутки во избежание явлений токсикоза и кумуляции.

Кроме сонной терапии, применяется лечение **и н с у л и н о м** (гипогликемия и шоки), **с у д о р о ж н а я т е р а п и я**, **с у л ь ф о з и н о т е р а п и я**, **о р г а н о т е р а п и я** и пр.

Из физиотерапевтических мероприятий применяют длительные теплые ванны, влажные укутывания, общесветовые ванны, облучение ультрафиолетовыми лучами, электрическое поле ультравысокой частоты.

**ЭНЦЕФАЛИТЫ.** Энцефалит клещевой. **С и м п т о м ы.** Наиболее характерны следующие симптомы: дистимический синдром, шизофреноподобный, психопатоподобные состояния, а в тяжелых формах — слабоумие.

**Э т н о л о г и я** и пр. см. *Заболевания нервной системы*.  
Энцефалит эпидемический. **С и м п т о м ы.** В острой стадии наблюдаются делириозные, апатические, маниакальные и депрессивные состояния. В хронической стадии психические расстройства занимают большое место. В зависимости от преобладания тех или иных психопатологических симптомов, могут быть выделены следующие формы: 1) **а с т е и ч е с к а я** с повышенной пстоша-емостью нервной системы — при отсутствии явлений паркинсонизма; 2) **а д и н а м и ч е с к а я** с замедлением двигательных и психических актов — при явлениях паркинсонизма; 3) **г ц п е р-Д и н а м и ч е с к а я**, большей частью у детей, с усилением подкиж-

ности, побуждений и пр.; 4) шифреноподобная, галлюцинаторно-параноидная; 5) психосизорная с арезией, нарушением схемы тела, обманами чувств без развития бреда и выраженного слабоумия. Остальное — см. гл. III *Заболевания нервной системы*.

**ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС (ЭПИЛЕПСИЯ)** см. *Нервные заболевания*. Тяжесть состояния обусловлена тем, что эпилептические припадки протекают сериями, что резко истощает больного, вызывает нередко повышение температуры и нередко заканчивается смертью.

Рекомендуется:

Rp. Hexenali 1,0

D. t. d. N. 4 in amp.

S. Растворить содержимое ампулы в 10 мл свежеприготовленной дистиллированной воды. Вводите 6—10 мл внутримышечно с последующей дачей:

Rp. Chlorali hydrati 1,0

Mucilapnis amyli Aq.

destill. aa 25,0

MDS. На одну клизму (вводить медленно, предварительно опорожнив кишечник)

К крайним мерам относятся: а) спинномозговая пункция — выпустить 20—40 мл спинномозговой жидкости (не следует применять в детском возрасте!); б) пневмокрания — выпустить 10—20 мл спинномозговой жидкости и тут же ввести в спинномозговой канал 10 мл воздуха; в) кровопускание 100—200 мл (при достаточной упитанности); г) пиявки на затылок; д) легкий эфирный и хлороформный наркоз.

Добавление I

## ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОФИЗИОЛОГИИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ВОЗБУЖДЕНИЕ И ТОРМОЖЕНИЕ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА.** Эти взаимно связанные процессы непрерывно протекают в коре головного мозга и определяют его деятельность. Изучая явления торможения, И. П. Павлов разделил их на два вида: внешние и внутренние. Торможение, возникающее в опытах с условными рефлексами при применении сильного постороннего раздражителя, И. П. Павлов назвал внешним. Характерной особенностью этого торможения является то, что оно возникает быстро, почти немедленно после применения нового сигнала. Другим видом торможения является внутреннее торможение. В то время как внешнее торможение возникает сразу, внутреннее торможение вырабатывается постепенно. Обязательным для возникновения внутреннего торможения условием является неподкрепление условного раздражителя безусловным. В результате наступает угасание условного рефлекса. Процесс торможения дает возможность дифференцировать различные раздражения, что имеет важнейшее значение для организма, дает возможность лучшей ориентировки его во внешней среде.

Распространение нервного процесса возбуждения в головном мозгу носит название *иррадиации*, а сосредоточение его и определенном участке — *концентрации*. Помимо иррадиации и концентрации, в коре головного мозга имеет место явление, получившее название *индукции*. Явление индукции заключается в том, что в определенных условиях концентрированное возбуждение вызывает в окружающем участке коры головного мозга противоположный эффект, т. е. торможение, и, наоборот, торможение может усиливать возбуждение. В каждый данный момент процессы возбуждения и торможения находятся в сложном взаимодействии.

Кроме той системы сигнализации, которая имеется у животных и связана с восприятием различных сигналов, сочетающихся с безусловными раздражителями так называемой первой сигнальной системы, у человека на пути его исторического развития, создалась еще более сложная и совершенная система сигнализации, связанная со словом — *речью*. Это, по Павлову, вторая сигнальная система. Условная связь в коре головного мозга человека образуется не только под влиянием непосредственного раздражения, но и под влиянием «сигналов сигналов» — в виде слов, речи. Сигнальное значение слова связано не с простым звуко сочетанием, а с его смысловым содержанием.

В основу выделения типов нервной системы, формирующихся в процессе жизни, И. П. Павлов положил три основных функциональных свойства нервной системы. Основными свойствами, характеризующими деятельность нервной системы, являются:

1. Сила и слабость основных нервных процессов — возбуждение и торможение. По принципу силы животные делятся на две группы — сильная — с высоким и слабая — с низким пределом работоспособности.

2. Уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Под уравновешенностью понимается соотношение между силой возбуждения и торможения.

3. Подвижность и инертность процессов возбуждения и торможения с быстрой или медленной сменой возбуждения на торможение и обратно.

В основу павловской классификации типов нервной системы положено индивидуальное различие указанных основных свойств. Павлов выделил четыре основных типа нервной системы:

1. Тип сильной по неуровновешенности нервной системы, который характеризуется преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения («безудержный тип»).

2. Тип сильной уравновешенной нервной системы с большой подвижностью нервных процессов («живой тип»).

3. Тип сильной уравновешенной нервной системы с малой подвижностью нервных процессов («спокойный тип»).

4. Тип слабой нервной системы со слабым развитием как возбуждения, так и торможения («слабый тип»).

Между этими четырьмя типами имеется множество промежуточных типов.

Каждая нервная клетка имеет свой предел работоспособности, пагубности, предел для раздражений, дальше которого наступает истощение клетки. При наступлении истощения в коре головного мозга появляется за пределное торможение, имеющее целью сохранить клетке жизнь. Если такое торможение охватывает всю кору головного мозга и распространяется! максимально вниз и вглубь больших полушарий, то наступает сон; если же торможение коры неполное, частичное, то, по Павлову, возникают пптнотидные состояния, гипнотидные фазы.

Ослабленная нервная клетка (равно как п засыпающая) обнаруживает при этом ряд качественных особенностей. Такая клетка па разнот силы раздражения отвечает то одинаковым эффектом (так называемая уравнительная фаза), то на слабые раздражения реагирует резче, чем на сильные (так называемая а р а д о к с а я б-I! а я фаза), то на положительное раздражение не отвечает, а па отрицательное реагирует положительно (так называемая у л ь т р а п а р а д о к с а л ь н а я фаза), то на все раздражители не дает никакого эффекта (так называемая н а р к о т и ч е с к а я фаза).

## СИНДРОМЫ

Аментный синдром. С и м п т о м ы . Спутанность, бессвязность мышления, дезориентировка, колебания аффектов, иногда обманы чувств и двигательное беспокойство.

Л е ч е н и е

Rp. Sol. -Glucosi 40% 30,0

Sol'. Magnesii sulfurici 25% 30,0

Steriligtur!

DS. П6 10—15 мл впутрпвпно

Показано переливание крови.

При возбуждении см. *Аментное возбуждение, Добавление IV.*

Амнестический (корсаковский) синдром. С и м п т о м ы . Оби́гая адинамия. Ослабление способности запоминания, дезориентировка, особенно во времени, конфабуляции при сравнительной сохранности мышления большого и внешней корректности поведения.

Л е ч е н и е . Подкожные уколы 0,5 ил 0,1% раствора азотно-кислого стрихнина, внутривенные уколы витамина В<sub>1</sub>.

Апато-абулический синдром. С и м п т о м ы . Вялость, апатия, отсутствие инициативы, побуждений, ослабление активной функции воли с вниманием.

Л е ч е н и е . Впутривенное введение 1% фенамина по 1—>2 мл и витаминов (В<sub>1</sub>, никотиновой, аскорбиновой кислоты).

Астено-адинамический синдром. С и м п т о м ы . Понижение работоспособности, утомляемость, забывчивость, плохой сон и а аппетит.

Л е ч е н и е . 25 мл 25% глюкозы внутривенно ежедневно или через день в сочетании с витаминотерапией.

Рекомендуется также аптиретикулярная сыворотка Богомольца (АП.С), переливание крови, а также физиотерапевтические мероприятия: общее облучение ультрафиолетовыми лучами, теплые ванны, электрическое поле УВЧ на голову в атермическх дозах.

Галлнцнваторно-параноидный синдром. С и м п т о м ы . Несистематизированный бред преследования и воздействия, бредовое истолкование окружающего, наличие обманов чувств.

Л е ч е н и е . Но 5 единиц инсулина.натошак 2 раза в течение часа с последующей (через  $\frac{1}{2}$ —1 час) дачей 50—100 г сахара.

При затяжном течении — инсулшювая гипогликемия, а также лечение прерывистым сном.

См. также *Возбуждение галлюцинаторно-параноидное, Добавление IV.*

Гебефренический синдром. С и м и т о м ы . Черты дурашливости, манерность, кривлянке, вычурная речевая продукция ига фоне несколько повышенного настроения или безразлпчия.

Дедприозный синдром. Э т и о л о г и я . Наблюдается при инфекциях, интоксикациях, травмах черепа и пр.

**Симптомы.** Наплыв бредовых и галлюцинаторных явлений при помрачении сознания, иллюзорное восприятие окружающего, двигательное беспокойство и быстро сменяющиеся аффекты.

**Лечение.** Длительность от нескольких дней до недель.

Наряду с антитоксическими средствами (глюкоза, глюкоза и гипосульфит натрия и пр.), следует добиваться наркотического действия. Рекомендуется:

Rp. Sol. Magnesii sulfurici! 5% 50,0

Steriliscitur!

DS. По 5 мл внутривенно или внутримышечно, повышая по 1—2 мл, но не выше 10 мл; в среднем 10—15 вливаний

При появлении осложнений (рвота, тошнота, падение пульса и пр.) ввести внутривенно хлористый кальций.

Если результаты недостаточны, следует добавить наркотики из группы барбитуратов.

**Депрессивный синдром. Этиология.** Наблюдается, кроме маниакально-депрессивного психоза, в начальном периоде шизофрении, при органических психозах, артериосклерозе головного мозга, психических реакциях и пр.

**Симптомы и лечение см. Маниакально-депрессивный психоз.**

При возбуждении см. *Возбуждение депрессивное, Добавление IV.*

**Ипохондрический синдром. Этиология.** Наблюдается при самых разнообразных заболеваниях, в том числе при шизофрении, развиваясь из галлюцинаторно-бредовых заболеваний, из аффективных состояний и пр. ■

**Симптомы.** Преувеличенные опасения действительных или воображаемых заболеваний, причем все внимание больного концентрируется на ощущениях в тех или иных частях тела и все поведение определяется этими опасениями за свое здоровье.

**Лечение** представляет большие трудности. В ряде случаев некоторый терапевтический успех дает сочетание инсулиновой гипогликемии с 1% никотиновой кислотой (по 5—10 мл внутривенно или внутримышечно 1—2 раза в день). При сенестопатиях с ипохондрическим бредом («вторичным») у больных шизофренией положительный эффект дает новокаиновая блокада по Вишневскому.

**Кататонический синдром. Симптомы.** Различают кататонический ступор и кататоническое возбуждение, которые могут сменяться. Сочетание гиперкинетических и ступорозных симптомов (мутизм, негативизм, стереотипия, гримасничание, импульсивные действия и пр.). Состояние ступора заключается в неподвижности при наличии расслабления мускулатуры или, наоборот, ее напряжения, скованности. На первый план выступает снижение активности и стимулов к деятельности, понижение волевых импульсов (см. также *Ступор*). При кататоническом возбуждении у больных наблюдается большей частью монотонное проявление двигательных и волевых импульсов, разорванная речь, иногда они производят самые нелепые и агрессивные действия.

**Лечение см. Шизофрения и Возбуждение (кататоническое).**

**Оглушенность. Симптомы.** Погруженность в полудремоту, неясное восприятие окружающего. Способность запоминания понижена, внимание при; л. кается с трудом, мышление затруднено.

**Лечение.** Вливание 10—20 мл 40% раствора глюкозы ежедневно, можно в комбинации с 10 мл 25% гипосульфита натрия. Кроме того, показано подкожное введение кислорода, кофеина, коразола. При длительной оглушенности — спинномозговая пункция. При возбуждении — см. *Возбуждение на фоне оглушенности, Добавление IV.*

*Добавление III*

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПСИХИЧЕСКИ ВОЛЬНЫМ

Исходным положением должны служить следующие слова И.П.Павлова: «Надо ждать очень значительного увеличения процента выздоровления, если к физиологическому покою посредством торможения присоединить нарочитый внешний покой таких больных, а не содержать их среди беспрерывных и сильных раздражений окружающей обстановки». Для соблюдения этого условия необходима прежде всего четкая профилизация отделения. Недостаточно четкая профилизация ведет к тому, что больные с острыми формами заболевания находятся совместно с так называемыми хроническими больными. Большое значение имеет также правильное распределение больных по палатам внутри отделения, в зависимости от их психического состояния, своевременный перевод больного из беспокойного отделения в более спокойное. Чрезвычайно существенное значение имеет правильно организованный режим дня, щадящий режим, отсутствие шума, криков, громких разговоров персонала и других вредно действующих больничных раздражителей, как хлопанье дверей и пр. Сюда же относится организация ухода в отделении. Уют, чистота и порядок в отделении действуют успокаивающим образом на больных и дисциплинируют их. Культура ухода за больными, уважение и любовь к ним, повседневная забота о них, выдержанное, ровное поведение персонала — вот что должно лечь в основу правильного ухода за психически больным. Очень важно длительное пребывание на воздухе, прогулки как летом, так и зимой. Это способствует ослаблению возбуждения, улучшает сон, аппетит.

Больного следует ограждать от отрицательно действующие на него факторов уже при поступлении. Ответственная роль в этом отношении принадлежит персоналу, работающему в приемном покое. Режим дня отделения должен соблюдаться строжайшим образом (часы ночного сна, проведения медицинских манипуляций, принятия пищи, часы послеобеденного отдыха, трудовой режим и пр.), так как это создает у больного положительный условный рефлекс.

Наряду с лекарственным режимом, чрезвычайно велика роль психотерапии и гипноза. «Теперь мы все яснее сознаем, что происхождение болезни не менее сложно, чем сам организм, в котором развращается болезнь, что наши воззрения упрощают

весь сложный процесс, приводящий к болезни, что эмоциональные воздействия могут часто оказывать во много раз больше влияния, чем какой-либо физический фактор, что слово может наносить глубокое изменение во всем организме» (И. П. Павлов). С этих мало исках позиций психотерапия может применяться в виде как охранительной, так и стимулирующей терапии, а также с целью снятия патологического стереотипа.

**Т р у д о в а я т е р а п и я** в свете павловского учения является одним из основных методов лечения психически больных, стимулирующих корковую активность, а не только средством занятости или использования остаточной трудоспособности больных, как полагали раньше. Для проведения трудовой терапии в психоневрологических больницах в каждом отделении надо выделить соответствующее помещение, в котором в точно определенные часы, предусмотренные режимом дня, больные по назначению лечащего врача и под руководством и наблюдением специального инструктора участвуют в трудовых процессах. Труд больных надо обязательно индивидуализировать, в зависимости от особенностей их состояния профессиональных навыков, интересов и доступности трудовых процессии, в некоторых случаях возможны и полезны работы на свежем воздухе (в огороде, саду, на дворе и т. д.), выполняемые под наблюдением персонала. По мере улучшения состояния больного, с разрешения врача, необходимо направлять его из отделения на трудовые процессы в общебольничные лечебно-трудовые мастерские. Врач обязан строго регламентировать дозировку труда больного как в отделении, так и в общих мастерских больницы. Необходимо добиваться того, чтобы больные приспосаблились к требованиям общественно-производственной жизни в соответствии со степенью психической сохранности. При лечении трудом важно иметь в виду содержание трудовых процессов, правильно выбирать такие занятия, которые имеют практическое значение и делают больных более социально полезными.

При простой и кататонической форме шизофрении или других формах заболевания эффект трудовой терапии сказывается в том, что частично преодолевается аутизм и негативизм. Вместе с тем при кататонии однообразный труд может углубить автоматизм и стереотипии. Трудовая терапия противопоказана при соматических состояниях, требующих покоя, и при резком возбуждении.

**К у л ь т у р н о е о б с л у ж и в а н и е** больных должно быть политически целеустремленным, многообразным, эмоционально насыщенным и проводится под врачебным контролем в плане павловского охранительного режима. Проведение культработы среди больных должно включать следующие элементы: обеспечение больных художественной литературой, читка газет и журналов, демонстрация кинокартин, настольные игры (шахматы, шашки, домино и пр.), художественная самостоятельность с широким привлечением больных. Руководить культработой среди больных в крупных больницах должен специальный сотрудник (инструктор по культработе).

**Патронаж.** Одним из видов обслуживания психически больных является патронаж. В практике психоневрологического обслуживания населения применяется: 1) как больничный, так и внебольничный

патронаж. Больничный патронаж предназначается для обслуживания больных-хроников, выписавшихся из психоневрологических больниц, но нуждающихся в специальном попечении, лечении, уходе и материальной помощи. Помещению на больничный патронаж подлежат больные беспокойные, опасные для себя и окружающих, больные с повышенной сексуальной возбудимостью, слабые и неопытные, с тяжелыми соматическими заболеваниями, страдающие заразными болезнями и находящиеся на принудительном лечении. В небольничный психиатрический патронаж назначаются для обслуживания психических больных, не находящихся на больничном лечении. Это спокойные — хроник из числа содержащихся в психиатрических больницах, а также из числа больных, состоящих на учете внебольничной психиатрической организации. Внебольничный психиатрический патронаж организуется при областном, краевом и городском здравоохранении и имеет смету на свое содержание. В городах, где имеются психоневрологические диспансеры, внебольничный патронаж организуется при последних. Прием на патронаж, а также решения о прекращении пособий по патронажу производятся специальной комиссией.

#### Добавление IV

#### СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

**Возбуждение острое.** **Э т и о л о г и я .** Наблюдается при многочисленных психических заболеваниях, при инфекциях, интоксикациях, травмах черепа, шизофрении, маниакально-депрессивном: психозе, эпилепсии, истерии на фоне страхов, галлюцинаций, при состояниях резкой тревоги и тоски, на фоне острого истощения, при больших потерях крови и пр.

**С и м п т о м ы .** Возбуждение связано с более или менее выраженным двигательным и речевым беспокойством, страхами и пр. При резком возбуждении больные представляют опасность для себя и для окружающих.

**Т е ч е н и е** — от часов до недель и месяцев.

**Л е ч е н и е .** В целях быстрого купирования острого психомоторного возбуждения разнообразного генеза, а также для экстренной эвакуации больного рекомендуется:

Вр. Sol. Apomorphini hydrochlorici 0,5% 10,0 St/riliset.ur! S. По 0,5—1 мл подкожно, через 1—2 часа повторить

Если апоморфина нет или больной плохо его переносит, дают омнопон. Наркоз наступает через 10—15—30 минут и длится 1/2—3 часа; если одна инъекция не достигает цели, то при условии контроля над пульсом через 2 часа ее можно повторить.

Морфин и хлоралгидрат противопоказаны, так как они увеличивают внутричерепное давление и усиливают возбуждение.

При необходимости удержать больного в постели следует во избежание повреждений уложить его на спину и удерживать за середину предплечий, плечи, бедра, не сдавливая при этом грудь, жи-



вот, шею. Для влажных обертываний надо пользоваться простынями, смоченными в воде, а сверху накрыть больного теплым одеялом. На дому или в диспансере необходимо выяснить домашнюю обстановку, наличие в распоряжении больного опасных предметов, характер его агрессивных тенденций и, в зависимости от этого, наметить лечение, в первую очередь безболезненную иммобилизацию.

#### Отдельные виды возбуждения

Способы купирования возбуждения должны быть разными и прежде всего зависеть от характера возбуждения, а затем от патологической сущности заболевания и индивидуальных особенностей больного. Схематично можно говорить о двух видах возбуждения. Ео-первых, о координированном характере возбуждения, когда двигательные проявления носят координированный характер и больной нападает на окружающих, принимая их за своих врагов и т. д. Этот вид возбуждения сочетается обычно с яркой психопатологической продукцией. Здесь целесообразно применять преимущественно наркотические средства (главным образом барбитураты), которые не только снижают возбуждение, но и оказывают благотворное влияние на общее состояние, играя, по И. П. Павлову, целбно-охранительную роль. Второй вид возбуждения — хаотический, дискоординированный. Двигательные проявления бессмысленны, часто стереотипны, психопатологическая продукция бедна. Для снятия возбуждения надо принимать средства, повышающие раздражительный процесс. — такие, как глюкоза и пр. Этим путем удастся снять инертное торможение коры, которое, по И. П. Павлову, способствует субкортикальному хаотическому возбуждению.

При тех формах возбуждения, которые обусловлены ослаблением активного (условного) торможения (при маниакальном, галлюцинаторном, параноидном), надо применять бром и сернокислую магнезию, которые усиливают и концентрируют тормозные процессы в коре головного мозга. Барбитураты в данном случае менее эффективны.

Возбуждение галлюцинаторно-параноидное. С и м п т о м ы см. *Параноидный и Галлюцинаторный синдром.*

Л е ч е н и е. Предварительно до применения инсулиновой терапии рекомендуется—

Rp. Sol. Omnoponi hydrochlorici 2% 1,0

S. По 1 мл подкожно 2 раза в сутки в течение 3 дней

Когда больной станет несколько спокойнее, назначают клизму.

Bp. Barbamyli 0,3—0,5

Sol. (hloral hydrati 1,5 Aq. destill. 25,0

DS. На одну клизму, повторять 2 раза в сутки в течение 3 дней

Если после 3 дней состояние мало изменится, надо перейти к гексеналу (или пептоталу), который вводят внутримышечно 2 раза в сутки в течение 3—4 дней.

Rp. Sol. Hexcnali 1,0

Aq. destill. 10,0

MDS. На 1 инъекцию внутримышечно Bp.

Sol. Pcnthotali 1,0

Aq. distill 10,0

MDS. На 1 шгъекцию внутримышечно. Оба раствора должны готовиться ex tempore

Вслед за тем переходят к вышеуказанной клизме (барбитураты, хлоралгидрат) и подкожному введению 2 мл 10% кофеина 2 раза в сутки. Ежедневно делать теплые ванны (37—38°) в течение Уз— 1 часа.

В тех случаях, где возбуждение носит особенно стойкий характер (это относится прежде всего к кататоши и гебефрении), показано курсовое лечение сульфозином. Рекомендуется:

Rp. Sulfuri depurati 1,0

01. Persicor. (01 vasel.) 100,0

1)S. Вводить внутримышечно, повышая через день дозы па 1 мл (начиная от 1 до 10 мл)

Возбаудение депрессивное. Тревожно-депрессивное. С и м п т о м ы см. *Депрессивный и тревожно-депрессивный синдром.*

Л е ч е н а е. Рекомендуется барбампл с кофеином по следующей прописи:

Rp. Sol. Barbamyli 5% 6,0-8,0—10,0

Sol. Coffeini natrio-benzoici 10% 2,0—2,5

Sterilisdur!

DS. Для внутривенной или внутримышечной инъекции. Куре до 20 инъекций

Указанные мероприятия по введению снотворных проводятся 1—2 раза в сутки в течение 3—4 дней. При повышенной температуре снотворные следует давать в меньших количествах, а еще лучше обойтись без них и применять сернокислую магнезию с бромом.

Возбуждение при инфекционных и токсических психозах. С и м п т о м ы см. *Аментивный, делириозный синдром и синдром оглушенности.*

Л е ч е н и е. Целесообразно сочетание возбуждающих средств со снотворными. Чем резче выражена спутанность, тем больше акцент следует ставить на возбуждающие средства. Начинают лечение с купирования оглушенности назначением возбуждающих средств, а именно 1—2 мл 10% раствора кофеина подкожно. Если состояние не улучшается, в особенности при недостаточно хорошем пульсе, надо добавить 1—2 мл 10% раствора коразола (или кора-мина) подкожно или внутривенно. Применение обоих средств требует последующего внутривенного введения 50 мл 40% раствора глюкозы. При необходимости инъекцию можно повторять каждые 2—3 часа.

Если возбуждение носит затяжной характер, надо «вести» внутривенно в одном шприце 15 мл 40% раствора глюкозы и 15 мл 25% гипосульфита натрия.

Если возбуждение выражено резко и если больного надо транспортировать, то, кроме возбуждающих средств, следует давать снотворные (при условии удовлетворительного соматического состояния и нормальной температуры).

Рекомендуется дать 5—6 мл 10% раствора гексенала (или 10—12 мл 5% раствора пентотала) внутривенно или внутримышечно, после чего назначают клизму из 2% раствора мединала 25 мл, а вслед затем подкожно 1—2 мл 10% раствора кофеина.

Морфина и хлоралгидрата следует избегать.

Если все указанные средства не помогают, следует прибегнуть: а) к спинномозговой пункции (выпустить 15—20 мл спинномозговой жидкости) и б) к эфирному наркозу.

Возбуждение кататоническое. С и м п т о м ы см. *Кататонический синдром*.

Л е ч е н и е. Исходя из принципа охранительного торможения (И. П. Павлов), одним из основных методов борьбы с возбуждением у больных шизофренией (в частности, при кататонии) является применение различных снотворных средств. Рекомендуется:

Rp. Barbamvli 0,3—0,5 Broinurali  
0,3—0,5 Codeini phosphorici  
0,015 Aq. destill. 50,0

DS. На клизму, 1—2 раза в сутки. К клизме целесообразно добавлять 5 капель настойки строфанта. Рекомендуется также:

Rp. Sol. Magnesium sulf. 25% 50,0  
Natrii bromati 5,0  
Medinali 0,5-1,5

DS. На клизму, один раз в сутки, вводить смесь в подогретом виде медленно и глубоко

На первом этапе заболевания, когда общесоматическое состояние удовлетворительное и температура не повышена, рекомендуется гексенал или пентотал.

Rp. Sol. Hexenali 10% 8,0—10,0  
S. Внутримышечно на одну инъекцию  
Rp. Sol. Pentothali 5% 10,0—15,0  
S. Внутримышечно на одну инъекцию

После того как больной уснул, ввести клизму со следующей смесью:

Rp. Sol. Medinali 2% 30,0—40,0—50,0 (!) Sol.  
Chloral hydrati 6% 15,0 DS. На одну клизму

Кроме того, подкожно вводят 2 мл 20% камфорного масла или 10% раствор кофеина, которые не только улучшают сердечно-сосудистую деятельность, но и усиливают снотворное действие наркотиков. Эти процедуры проводятся 2 раза в сутки.

Возбуждение мнимые. С и м п т о м ы см. *Маниакальный синдром*.

Л о ч е н и е. Прежде всего рекомендуется применение брома, который, усиливая торможение, ослабляет возбуждение (М. К. Петрова). Для усиления действия брома целесообразно сочетать его с сернокислой магнезией.

Rp. Sol. Natrii bromati 10% или 5% 10,0 Sol. Magnesium sulfurici  
40% 5,0—10,0 DS. В одном шприце на 1 внутривенное  
вливание или внутримышечную инъекцию

Вливание надо проводить один раз в день в течение 10—15 дней. Если эффект недостаточный, то, кроме указанного вливания, надо еще давать внутрь 2 раза в сутки:

Pr. Sol. Chlorali hydrati 0% 15,0—20,0  
Luminal) 0,1 .  
DS. На один прием внутрь

Если больной отказывается принимать лекарства, прибегают к клизме — 2 раза в сутки.

Rp. Sol. Chlorali hydrati 15,0—20,0  
Medinali (s. Barbamvli) 0,1 Aq.  
destill. 30,0 DS. На одну клизму

В крайнем случае там, где это возможно, следует прибегнуть к длительным, в течение 2—3 часов, ваннам.

Возбуждение, вызванное Сильными потерями крови. Лечение. Рекомендуется: морфин (2%) 1 мл с последующим вливанием физиологического раствора 500 мл и добавлением 100 мл глюкозы (50% раствор).

Возбуждение психогенного характера. С и м п т о м ы см. *Истерия, Реактивные психозы*.

Л е ч е н и е. Наряду с режимными мероприятиями и психотерапией, рекомендуется нижеуказанное курсовое лечение.

Rp. Sol. Natrii bromati 1—5% 5,0—10,0  
Sterilis; tur! DS. Внутривенное  
вливание

Эти вливания чередовать с

Rp. Sol. Magnesium sulfur. 25% 10,0—15,0 Sol. Glucosac 40%  
15,0—20,0 Ster! Psetnr! DS. Для внутривенного вливания  
в одном шприце

В ряде случаев показано лечение прерывистым длительным курсом (малыми дозами снотворных).

Возбуждение при травмах мозга. С и м п т о м ы см. *Травматические психозы*.

Л е ч е н и е. При травмах мозга с выраженными сосудистыми изменениями рекомендуются:

Rp. Sol. Glucosae 40% 20,0  
Sol. Acidi nicotinic: 1% 6,0 St  
ril Si tur!

DS. Для внутривенного вливания, один раз в сутки в течение 2 недель с повторным курсом через неделю

При выраженных аффективных расстройствах рекомендуется:

Rp. Sol. Magnesii sulfurici 25% (40%) 20,0 Steriliscitur! DS. По 5—10 мл внутривенно или внутримышечно

Во многих случаях уместно применять бром с кофеином:

Rp. Sol. Natrii bromati 0,5—1% 50,0  
Coffeini natrio-benzoici 0,05—0,25  
SterillS: ttir!

DS. Для внутривенных или внутримышечных инъекций, по 5—10 мл

Возбуждение при эпилепсии. С и м п т о м ы см. *Сумеречное состояние*.

Л е ч е н и е состоит в назначении хлористого кальция:

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 100,0  
Steriliscitur!

MDS. Для внутривенного введения, начав с 5 мл и доведя до 10 мл, один раз в сутки, вводить медленно

Если возбуждение носит хаотический характер, целесообразно назначить подкожно кофеин:

Rp. Sol. Coffeini natrio-benzoici 10% 1,0 S. По одной ампуле

и одновременно вводится бромистый натрий:

Rp. Sol. Natrii bromati 10% 30,0  
S. Для внутривенного или внутримышечного введения 5—10 мл

Если все эти мероприятия окажутся бессильными, надо прибегнуть к клизме из хлоралгидрата (можно одновременно с хлористым кальцием) (6% 15 мл) и мидокала (2% 5,0), которую повторять по 2 раза в сутки в течение 3—4 дней. Если больной все же будет оставаться в сумеречном состоянии, надо прибегнуть к спинномозговой пункции.

В тех случаях, когда двигательные проявления носят более координированный характер, внутримышечно или внутривенно вводят 10% раствор гексепала (или 5% раствор пентотала) по 1 мл.

В тех случаях (это относится и к другим видам возбуждения), когда ввести лекарственные вещества внутривенно или внутримышечно почему-либо не удается, начинают с подкожного введения 1% раствора апоморфина (0,4—0,6 мл).

Противопоказания и осложнения при применении средств, купирующих возбуждение

Барбитураты. Противопоказанием к применению барбитуратов являются болезни печени и почек, резкое истощение, увеличение щитовидной железы, высокая температура. При болезни сердца барбитураты следует давать в меньших дозах, чем указано выше, и, кроме того, обязательно сочетать с сердечными средствами (камфорой и пр.).

Хлоралгидрат не следует давать в больших дозах больным с вы-  
раженными сердечно-сосудистыми нарушениями, а также при травмах черепа. В этих случаях следует ограничиваться 0,6 г препарата 2 сутки. Хлоралгидрат противопоказан при алкогольных психозах<sup>^</sup> наркоманиях и отравлениях тетраэтилсвинцом.

Морфин и пантопон противопоказаны при алкогольных психозах; острым кататоническом возбуждении, психозах, вызванных тетра-  
этилсвинцом.

Сернокислая магнезия в редких случаях дает осложнения. Лучшим средством является внутривенное введение 10 мл 10% раствора хлористого кальция, который надо всегда иметь наготове.

При купировании возбуждения наркотическими и снотворными\* средствами следует иметь в виду возможность перехода глубокого, сна в патологический сон, в коматозное состояние<sup>^</sup>. Это требует усиленного наблюдения за больным. При ухудшении дыхания, цианозе лучшим средством является коразол (внутривенно вводят 2—3 мл 10% раствора коразола); если это средство не помогает, подкожно вводят 2 мл 0,1% раствора стрихнина и 1—2 мл 10% раствора кофеина. Если больной не пробуждается, то введение коразола, стрихнина, эфедрина надо повторить.

При передозировке морфина может наступить коматозное состояние. В этих случаях делают промывание желудка (даже если морфин введен подкожно, так как он быстро всасывается в желудок), под кожу вводят 0,5—1 мл 0,1% раствора сернокислого атропина.

## ГЛАВА V

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ<sup>1</sup>

**АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ.** Наблюдается обычно у детей, имевших проявления экссудативного диатеза в раннем возрасте, с неустойчивой нервной системой. Начинается у детей чаще всего в возрасте 2—3 лет (в период формирования речи, что требует тонкой регуляции ритма дыхания); первый приступ обычно возникает после повторных или тяжелых заболеваний дыхательных путей, повторные приступы могут возникать по типу условного птерорецептивного рефлекса.

**Симптомы и течение.** Периодически повторяющиеся приступы упорного кашля с одышкой в течение нескольких часов или 1—3 суток со светлыми промежутками различной длительности. Во время приступа у детей нередко повышается температура, наблюдается общее тяжелое состояние, пиноз, затрудненное дыхание, выдох шумный, удлинен; при выслушивании преобладают сухие свистящие хрипы, но могут быть и влажные хрипы всех видов, что нередко ведет к диагнозу пневмонии; только повторность приступов позволяет установить правильный диагноз. В некоторых случаях заболевание протекает в виде астматического бронхита.

**Профилактика** см. *Профилактика заболеваний дыхательных органов*. Выработка правильного дыхания, закаливание организма с раннего детского возраста (физкультура).

**Лечение.** Приступ должен купироваться с самого начала приемом внутрь эфедрина, теофедрине или адреналина под кожу, у некоторых лучший эффект оказывают препараты белладонны (астматол и т. д.). Горячая ножная ванна, банки; применения горчицы лучше избегать (запах). Между приступами — мероприятия, воздействующие на нервную систему — рациональное питание и общий режим, широкое пользование свежим воздухом. Тренировка дыхания путем обычной и лечебной физкультуры и специальных дыхательных упражнений.

Rp. Sol. Adrenalin! hydrochlorici (1 : 1 000) 10,0 S.  
0,3—0,5 на инъекцию

Rp. Ephedrin 0,005—0,025 (в зависимости от возраста)  
Sacchari albi 0,2 M. f. pulv. D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Rp. Theophedrin в табл. N. 10  
DS. По  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ —1 таблетке при приступе, не более 2 раз в сутки

<sup>1</sup> Дозировки лекарственных веществ детям см. стр. 708.

**АСФИКСИЯ (ЗАДУШЕНИЕ) НОВОРОЖДЕННЫХ** см. гл. VII, *Акушерство*.

**АТЕЛЕКТАЗ ЛЕГКОГО (ATELECTASES PULMONUM).** Нередко наблюдается у новорожденных детей, родившихся в асфиксии, и у недоношенных.

Если ателектаз полный, ребенок гибнет от невозможности газообмена в легких. Если часть легких расправилась, то жизнеспособность организма восстанавливается и постепенно легкие расправляются целиком.

**Симптомы и течение.** Общее состояние тяжелое, цианоз, одышка, нестойкие мелкие крепитирующие хрипы, исчезающие после нескольких глубоких вдохов, ослабленное дыхание.

**Лечение и профилактика.** Грелки к ногам, кислород, высокое изголовье. Внутрь 0,5% раствор кофеина по одной чайной ложке 3—4 раза в сутки, горячие ванны (39—40°), горчичные обертывания.

В тяжелом состоянии инъекции лобелина с кофеином.

Пр. Sol. Lobelini hydrochlorici 1% 1,0

D. t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,3 на инъекцию 2—3 раза в день Rp.

Sol. Coffeini natrio-benzoici 10% 1,0

I), t. d. N. 6 in amp.

S. По 0,2—0,3 на инъекцию 2—3 раза в день

**АТРЕЗИЯ (ОТСУТСТВИЕ) ЗАДНЕПРОХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ (ATRESIA ANI).** Врожденное уродство. **Симптомы.** Отсутствие мекония и заднепроходного отверстия.

**Лечение.** Оперативное, немедленное, заканчивающееся обычно сохранением жизни новорожденного.

**АНЕМИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ВРОЖДЕННАЯ (ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ).** Анемия новорожденных гемолитического характера возникает внутриутробно вследствие несовместимости крови матери и плода: поступление в кровь плода фактора антирезус-агглютининов от матери может привести к распаду эритроцитов, поражению печени и центральной нервной системы.

**Симптомы и течение.** Резкая желтуха с первых дней жизни. Быстрое падение гемоглобина и эритроцитов, эритробла-стоз. Часто увеличение печени и селезенки. Смерть может наступить в первые дни жизни, если заболевание не распознано и не предприняты нужные мероприятия.

**Распознавание.** Исследование крови матери и ребенка на резус-фактор. Вышеприведенные симптомы при резусотрицательной крови матери и резусположительной крови ребенка подтверждают диагноз.

**Лечение.** С первого дня жизни переливание резусотрицательной крови.

**Профилактика.** Беременные женщины, у которых погибали дети в первые дни жизни с симптомами желтухи, малокровия или общей водянки, должны быть взяты на специальный учет. При рождении ребенка немедленно делать переливание резусотрицательной крови (шюттршуповинно).

**БРОНХИТ ОСТРЫЙ (BRONCHITIS ACUTA).** Чаще всего присоединяется к острому катарру верхних дыхательных путей, наблюдается также при острых инфекционных заболеваниях, особенно при вирусном гриппе, продромальном периоде кори, катарральном периоде коклюша.

**Симптомы и течение.** Частый кашель, сухой или влажный, ухудшение общего состояния, повышение температуры (иногда заболевание протекает без повышения температуры). Отсутствие притупления перкуторного звука и неизменное дыхание при наличии сухих и влажных хрипов, рассеянных в обоих легких. Затяжное течение бронхитов наблюдается у детей раннего возраста, страдающих рахитом, экссудативным диатезом, у детей дошкольного и школьного возраста — при наличии аденоидных разрастаний, воспалительных явлений в придаточных полостях носа и увеличении миндалин.

**Распознавание.** Следует исключить воспаление легких, туберкулез бронхальных желез.

**Профилактика.** Оберегать детей от инфекционных болезней, осложняющихся бронхитом (грипп и др.). Закаливание, раннее распознавание и лечение рахита.

**Лечение.** При повышенной температуре — постельное содержание в хорошо проветриваемой комнате, а при нормальной — прогулки на свежем воздухе. Кварц, горячая ванна, горчичники и горчичное обертывание. Детям старше года — банки. При сухом кашле — кодеин, доверов порошок; при влажном — минеральная вода (боржом), паровая ингаляция и отхаркивающие.

Доверов порошок дается только детям старше года из расчета: столько сантиграммов порошка, сколько лет ребенку. Одновременно общеукрепляющее лечение: препараты железа, кальция, фитин, витамины.

Up. Codeini phosphorici 0,1 Aq.  
destill. 100,0  
MDS. По V «чайной ложки 3 раза в день детям до года по 1 чайной ложке детям от 1 года до 3 лет

Rp. Codeini phosphorici 0,005  
Sacchari 0,2 M. f. p. D. t. d.  
N. 12

S. По 1 порошок 3 раза в день (для детей старше 3 лет)

Rp. Liq. Ammonii anisati  
Natrii benzoici или Natrii bicarbonici aa 2,0  
Aq. destill. 100,0  
MDS. По 1 чайной ложке 4 раза в день

Rp. Inf. rad. Senegae ex 2,0 : 100,0  
DS. По 1 чайной ложке 4 раза в день

**БРОНХИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (BRONCHITIS CHRONICA)** см. Пневмония хроническая.

**БРОНХАДЕНИТ** см. Туберкулез.

**ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ** см. Врожденные пороки развития.

**ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ.** Заячья губа — расщепление верхней губы, волчья пасть — расщепление твердого и мягкого неба.

При этих пороках нарушен акт сосания.

При невозможности сосания груди — сцеживать молоко и кормить ребенка через резиновую соску или с ложечки. Операция возможна у крепких детей: при заячьей губе — с 2—4-месячного возраста, при волчьей пасти — в 5—6 лет.

**ГАСТРОЭНТЕРИТ ОСТРЫЙ (GASTROENTERITIS ACUTA).** Причиной: перегрузка чрезмерно жирной или недоброкачественной пищей. Кишечная инфекция.

**Симптомы и течение.** Повышенная температура, головная боль, общее недомогание, потеря аппетита, обложенный язык, рвота, понос, боли в животе.

**Профилактика.** Правильный пищевой режим; гигиеническое Приготовление ПИЩИ:

**Лечение.** Вначале слабительное (касторовое масло, венское питье). При упорной рвоте — промывание желудка.

Постельный режим, тепло на живот. Диета: первый день — чайно-водная; со 2-го дня — сладкий чай с сухарем, кисель, мясной бульон, овощной процеженный суп; с 3—4-го дня — картофельное пюре, кефир, каши; с 5—6-го дня — постепенный перевод на обычную диету. При переходе заболевания в затяжную форму — дезинфицирующие (бензоафтол, салол) или вяжущие (тапнальбин, висмут).

Rp. Saloli 0,1  
Calcii carbonici 0,2  
M. f. p. D. t. d. N. G  
S. По 1 порошок 2—3 раза в день

Rp. Benzonaphthoj  
Tannalbin aa 0,25—0,3  
M. f. p. D. t. d. N. 6  
S. По 1 порошок 2—3 раза в день

Rp. Bismuti subnitrici 0,2—0,3 D. t. d. N.  
0 S. По 1 порошок 3 раза в день

**ГЕЛЬМИНТОЗЫ** см. Глистные заболевания.

**ГИПОТРОФИЯ. ПОНИЖЕННОЕ ПИТАНИЕ.** Наблюдается только в раннем возрасте. Причины: недоедание количественное или качественное; острые инфекционные заболевания; часто повторяющиеся острые катарры верхних дыхательных путей; длительные или часто повторяющиеся острые желудочно-кишечные заболевания (особенно дизентерия); туберкулез и сифилис.

**Симптомы и течение.** Основной признак (при различных формах заболевания) — истощение. При гипотрофии I степени — подкожножировой слой умеренно уменьшен, только на туловище и животе несколько теряется упругость кожи; в весе ребенок отстает примерно до 20%; рост не страдает. Общее состояние остается удовлетворительным.

При гипотрофии II степени—более сильная потеря жира на туловище, конечностях и отчасти на лице; наблюдается и некоторая отсталость в росте. Иодкожжировой слой в значительной мере исчезает на туловище, на животе кожа становится очень тонкой. Исчезает жир на конечностях и в области ягодиц. Кожа теряет эластичность, становится бледной, вялой, сухой, легко собирается в складки, плохо расправляется. На отдельных участках кожи иногда заметно шелушение, геморрагическая сыпь или (иногда) пигментация. Исхудание заметно и на лице; тургор понижен. Мышцы истончаются; отставание в весе (до 40%).

Наряду с отставанием в весе и росте, наблюдается и понижение моторных функций.

При гипотрофии III степени (или атрофии) жир исчезает везде. Лицо имеет форму треугольника, глаза и щеки западают, на лбу появляются морщины, "скулы выдаются, подбородок заострен. Ребенок похож на старика. На бледном фоне лица резко выделяется большой рот с яркокрасными губами. Нос и конечности холодные, нередко синеватого цвета. Выражение лица страдальческое. На туловище и конечностях кожа висит складками. Живот втянут или вздут вследствие усиленного образования газов и атонического состояния кишечника и брюшной стенки. Нередко на ягодицах, мошонке наблюдается мокнувшая эритема и язвочки. Мышцы истончены. Тонус их большей частью повышен. Дыхание часто поверхностное, замедленное, тоны сердца приглушены. Отсталость в весе на 50% и даже больше. Заметна отсталость и в росте. Статические функции резко отстают. Температура неустойчива; обычно ниже нормы, но может давать повышение на 1—2°.

**П р о ф и л а к т и к а .** Устранение причин, приводящих к гипотрофии: ограждение от инфекционных заболеваний, своевременное принятие мер при заболевании ребенка. Правильное естественное вскармливание. Своевременное введение прикорма и витаминов, в частности, А и D, при отнятии от груди назначать полноценное питание. Правильный уход, режим, достаточное пребывание на свежем воздухе.

**Л е ч е н и е .** Исходя из физиологического учения И. М. Сеченова и И. П. Павлова об организме как единой целостной системе во взаимодействии с окружающей средой и ведущей роли нервной системы в физиологических и патологических процессах в организме, лечение гипотрофии должно быть построено соответственно этому принципу. Экспериментальные работы И. П. Павлова и его ближайшего ученика Н. И. Красногорского показали, что при голодании организма отмечается пониженная возбудимость коры больших полушарий мозга, понижение не только условных рефлексов на пищу, но и безусловных. Это приводит к понижению аппетита и всей пищеварительной способности желудочно-кишечного тракта. Такое же влияние на желудочно-кишечный тракт оказывают инфекционные заболевания, недочеты ухода, режима и воспитательной работы. Поэтому при лечении детей, страдающих гипотрофией, необходима прежде всего правильная организация среды (ухода, режима, воспитания, питания), а при наличии инфекционного процесса — и соответствующего лечения. При подкормании — докармливание сце-

женным грудным молоком, если ребенок находится на грудном вскармливании, или соответствующей смесью коровьего молока.

При гипотрофии I степени полноценное питание.

При гипотрофии II степени, в связи с пониженной усвояемостью пищи, ребенок получает вначале V, или 1/2 а полагающейся ему по объему пищи; постепенно под контролем веса и стула объем пищи увеличивается. Обязательно грудное молоко 300,0—400,0; остальное питание — в зависимости от возраста (см. *Питание детей*). Концентрированную пищу в виде сливок, масла, творога следует вводить осторожно в тот период, когда ребенок начинает восстанавливать свой вес. Вначале лечение следует начинать с простых смесей (см. *Питание детей*). Когда питание ограничено, во избежание водного голодания давать ребенку 100—200 мл 5% раствора глюкозы, 100—150 мл физиологического или рингеровского раствора, воду или чай с добавлением фруктовых соков. Вводится такое количество жидкости, чтобы она вместе с пищей, получаемой ребенком, составляла тот объем пищи, который соответствует его возрасту (150 мл на 1 кг веса). Дается витамин А в виде рыбьего жира, витамин С (аскорбиновая кислота) от 100 до 200 мг ежедневно, в зависимости от возраста, а при показаниях — и другие витамины: D, B<sub>1</sub> и т. д. При пониженном аппетите назначается соляная кислота с пепсином (Sol. Acidi hydrochlorici dilutum 1—2% 100,0, Pepsini 1,0—2,0) по одной чайной ложке перед едой 3 раза в день или натуральный желудочный сок по V, — 1 чайной ложке 3 раза в день, а также панкреатин (Pan-creatini, Calcii carbonici) 2—3 раза в день через 1 час после еды. В тяжелых случаях — гемотерапия или серотерапия (инъекции человеческой крови или сыворотки 5—10 мл внутримышечно через день). Хороший эффект дает переливание крови — 8 мл на 1 кг веса (начинать с меньших доз — 30—40 мл), всего 3—4 переливания, один раз в 5 дней. Можно применять осторожно ультрафиолетовое облучение (при отсутствии малокровия). В последние годы с успехом применяется тканевая терапия по Филатову — подсадка (до 2—3 раз после рассасывания предыдущей подсаженной ткани) или алоэ (по 1 мл ежедневно внутримышечно — 10—12 инъекций).

При гипотрофии III степени (атрофии) дается ограниченное количество пищи (50—75% нормы), грудное молоко (300,0—400,0) дробными порциями 8—10 раз.

При отсутствии грудного молока дают пахтанье. Недостающее по объему количество пищи добавляется в виде жидкости (5% раствор глюкозы, физиологический или рингеровский раствор, вода). Постепенно к грудному молоку добавляют пахтанье, обогащенное углеводами: сахаром и мукой; затем простые блюда и подкисленные смеси: кислый В-рис, кефир, кашу, кисель, овощное пюре (по возрасту). Осторожно вводится концентрированная пища в виде южно-рога, мяса (в зависимости от возраста). После года жизни можно давать, наряду с грудным молоком, кислые смеси (см. *Питание детей*), кофе с молоком, простоквашу, овощной суп или бульон, кисель. Недостающее по объему количество пищи возмещается в виде жидкости до нормы. Постепенно под контролем аппетита, веса, стула объем пищи увеличивается. Вводится овощное пюре, творог, протертое мясо, белые сухари и т. д. При пониженном

аппетите лают соляную кислоту с пепсином, панкреатин. Можно давать также *Calcii glycerophosphorici*, *Feni glycerophosphorici* aa 0,15—0,2 два-три раза в день. В тяжелых случаях — гемотерапия в виде внутримышечных инъекций (всего до 10 инъекций) или переливание крови, тканевая терапия по Филатову или алоэ. Витамин С 100—200 мг в сутки дается с самого начала лечения. В период восстановления питания осторожно вводят рыбий жир. Остальные витамины — по показаниям.

Независимо от метода лечения необходимо и лечение физическими методами: пребывание на воздухе, массаж, гимнастика.

Выявленные воспалительных очагов, отитов, мастоидитов, пневмонии, а также сифилиса, малярии и т. д. и их обязательное лечение.

**ГЛИСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ГЕЛЬМИНТОЗЫ (HELMINTHIASIS). АСКАРИДЫ. Симптомы и течение.** Понижение аппетита, тошнота или рвота (обычно по утрам натощак), слюнотечение (ночью), поносы или запоры, боли в животе, часто в области пупка или подложечной. Иногда аскариды, собираясь в клубок, могут давать картину острого живота (см. гл. VI, *Хирургия*). Головные боли и головокружения, раздражительность, судорожные припадки.

Лечен и е. Накануне и в дни лечения дается легко усвояемая пища, бедная жирами (полужидкая ниша, белый хлеб и т. д.). Накануне лечения — на ночь солевое слабительное (английская или глауберова соль) по 2,0 на год жизни ребенка на прием в полустакане воды. Затем 2 дня подряд натощак или после легкого завтрака дают 3 порошка сантонина по 0,005 на год жизни (до 10 лет) (через час по порошку) или 2 порошка через 2 часа; через 1 час после последнего порошка — слабительное, через 1 час после слабительного — легкий завтрак. Курс лечения повторяется через 2—4 недели (если в кале окажутся яйца глистов). При отсутствии сантонина можно применять цитварное семя по 0,2—0,5 три раза в день в растертом виде с вареньем.

В последнее время успешно применяются таблетки санкафена (сантонина — 0,016, каломели — 0,0065, фенолфталеина — 0,016) по одной таблетке на каждый год жизни на курс лечения. Метод лечения: накануне делается очистительная клизма; утром стакан сладкого чаю с куском белого хлеба и первый прием таблеток санкафена, через 30 минут — второй прием таблеток санкафена, через 2 часа после второго приема — завтрак; на ночь ставит я очистительная клизма. На второй день лечения повторяется то же самое, только вместо клизмы дается на ночь слабительное (не назначать *Natrii sullurici* и *Magnesii sullurici*) — пурген, венское питье, ревень. **О с о б е н н о п р е д у п р е д и т ь** родителей и самих детей о запрещении во время лечения санкафеном, (каломель) кислых блюд (квашеной капусты, соленых огурцов, лимонов, шавеля и т. д.). При массовой гельминтизации избегать давать санкафен школьникам второй смены.

В упорных случаях аскаридоза применяют таблетки гексил-резорцина — по 0,1 на год жизни до 10 лет, от 10 до 16 лет — 1,0. Вся доза дается натощак в течение 1 часа за 3—6 приемов с теплым сладким чаем. Через 5 часов — легкий завтрак; на ночь или на сле-

дующее утро — слабительное. В день лечения и последующие 2—3 дня рекомендуется легко усвояемая пища; острые и кислые блюда исключаются.

**Ленточные глисты. Симптомы и течение.** Боли в животе, тошнота, рвота, понос или запор, нервные расстройства (головокружения), малокровие.

**Лечение** папоротником или тыквенными семенами, обязательно в стационаре. Дозы *Extr. Filicis maris aetherei* (разовые) по 0,5 на год жизни. Схема лечения: за 2 дня до лечения и во время лечения — легко усвояемая пища, бедная жирами, богатая углеводами; накануне лечения — солевое слабительное; ужин заменить сладким чаем. Утром натощак — клизма; через 20 минут после ее действия выпить в течение получаса  $\frac{1}{2}$ —1 стакан 1% содового раствора; через полчаса прием папоротника — желателен в капсулах, запивая их содовым раствором. Детям, не умеющим глотать капсулы, папоротник дается в сладкой каше, повидле, варенье. Через полчаса — прием солевого слабительного. Если содовый раствор вызывает рвоту, то папоротник запивается водой, слабительное дается через 1½ часа. Через 1½ часа после слабительного — легкий завтрак. Если через 2 часа после приема слабительного стул отсутствует, поставить клизму из воды температуры 22—25°. В случае отхождения паразита без головки повторять клизму до 4—5 раз.

**Лечение** тыквенными семенами (сырыми, давностью не более года); разовая доза по 50 г на 1 год жизни. Семена вместе с белой кожурой пропускают через мясорубку, заливают двойным количеством кипятка и ставят на водяную баню на медленный огонь на полчаса; затем фильтруют, семена отбрасывают, а жидкость выпивают в течение 1 часа. Через 4 часа после этого — слабительное и через полчаса, независимо от действия кишечника, — клизма. Есть разрешается после первого стула.

**Острицы. Симптомы и течение.** Зуд в области заднего прохода и половых органов; краснота и расчесы в этих местах, вульвовагинит; реже потеря аппетита, тошнота, боли в животе, бессонница, понижение трудоспособности, рассеянность, ночное недержание мочи. У девочек — опанпзм.

**Лечение.** Первый курс — лечение саптоипном, как при аскаридозе. В первый день лечения проводится тщательная уборка и омещения (мытье полов, мебели, окон, игрушек и т. д.), больному назначается гигиеническая ванна с тщательным обмыванием заднего прохода; меняется постельное- и носильное белье.

Второй курс проводится обязательно через 15—20 дней. В промежутке между курсами ежедневно ставится клизма на ночь из воды или 1% содового раствора, ежедневно утром и вечером обмывается область заднего прохода и половых органов; спать в закрытых трусиках; утром и вечером их снимать и кипятить или проглаживать горячим утюгом. Обязательно мытье рук перед едой и после пользования уборной, содержание в чистоте постели и помещения. Лечение необходимо проводить одновременно для всей семьи (всего коллектива). Во второй курс лечения можно вместо сантонина давать серу по 0,05 на 1 год жизни 3 раза в день" во время еды в те-

чиіііііі 6 дней подряд, затем перерыв 4 дня. Таких курсов проводят от Э до 6.

В последнее время детям после 2 лет рекомендуется фенотиазин (Phenothiazin). Разовые дозировки: детям 2—5 лет— 0,2; 6—9 лет— 0,3; 10—16 лет — 0,5. Способ применения: после легкого завтрака — по одному порошку каждый час, через 2 часа после третьего порошка — слабительное, после чего через час — завтрак; через 1 час после завтрака — очистительная клизма. Такое лечение повторяется в течение 4—5 дней подряд. При лечении фенотиазином моча приобретает красный цвет.

**ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБУХАНИЕ** (иногда ошибочно называется грудницей). Наступает у новорожденных, длится недели две. Л е ч е н и я не требует.

**ГРУДНИЦА. ВОСПАЛЕНИЕ ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВОРОЖДЕННЫХ (MASTITIS NEONATORUM).** С и м п т о м ы в т е ч е н и е. Припухание, покраснение п болезненность части железы, повышение температуры; часто образуется абсцесс.

Л е ч е н и е. Местно — сухое тепло. При подозрении на абсцесс — внутримышечно 50 000—100 000 единиц пенициллина в сутки В I", растворе пирамидона или 0,5% растворе новокаина, до исчезновения местного воспалительного процесса. При созревании абсцесса — разрез.

**ДИАТЕЗ НЕВРОПАТИЧЕСКИЙ.** В основе этого состояния лежит врожденная ненормальная повышенная возбудимость и истощаемость нервной системы. Уже с первых недель жизни ребенок проявляет повышенную возбудимость на внешние раздражения (стук, яркий свет, громкий голос и т. д.). Он вздрагивает, громко плачет, медленно успокаивается. Сон неглубокий, часто просыпается, много плачет. Аппетит понижен; быстрая насыщаемость, склонность к срыгиваниям, рвоте. Спазмические боли в животе. Легкая истощаемость нервной системы: быстрое утомление от сосания груди, от легкой физической нагрузки. К нервным симптомам относится потливость, похолодание конечностей, быстрая смена окраски кожи — бледность и покраснение. Все эти явления приводят к недостаточной прибавке в весе. По мере роста ребенка и развития нервной системы реакция на внешние раздражения становится более сложной: ребенок капризен, раздражителен, часто сердится, трудно подчиняется режиму дня. В возрасте 2—5 лет проявлениями невропатии являются головные боли, периодическая рвота с запахом ацетона изо рта; ацетон резко выражен п в моче. Аппетит понижается. Такие явления приводят к истощанию. По окончании приступа аппетит восстанавливается, и ребенок поправляется. Невропатический диатез сочетается с экссудативным.

Л е ч е н и е и п р о ф и л а к т и к а. Правильное воспитание, систематическое проведение режима питания. Полноценное питание, обогащенное овощами и фруктами; витамины А, С, В<sub>1</sub> (при склонности к рвоте), закаливание (пользование свежим воздухом, обтирания, теплые ванны, массаж, гимнастика). Из медикаментов — глицерофосфаты (Calcii glycerophosphorici 2—3 раза в день по 0,2—0,3, в зависимости от возраста), препараты кальция (5% Cal-i ii chlorati по 1 чайной ложке 3 раза в день в возрасте до 1 года в

10% — после 1 года, Calcii gluconici 0,2—0,3 три раза в день) в брома (0,5—0,25% Sol. Natrii bromati по 1 чайной ложке 2—4 раза в день).

Диатез экссудативный^ является как бы предрасположением к определенным заболеваниям. Проявления экссудативного диатеза рассматриваются как результат повышенной чувствительности к различным пищевым веществам: яйцам, молоку, сыру, меду, иногда ягодам, в частности, к клубнике. При грудном вскармливании проявления возникают в связи с особенностями питания матери.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Самые ранние проявления (с первых месяцев жизни, чаще с 3—4-го месяца): себоррея, молочный струп, опрелость, экзема, узелковая сыпь, крашгенша, географический язык, астматический бронхит, в более старшем возрасте — бронхиальная астма. У этих детей отмечается склонность к острым катаррам верхних дыхательных путей, к диспептическим явлениям. Периферические лимфатические узлы увеличены, в особенности шейные, аппетит неустойчив; повышенная возбудимость, раздражительность, беспокойство, плохой сон. С 6—8 лет кожные проявления почти исчезают, но может наблюдаться крапивница, отек Квинке.

Л е ч е н и е. Исходя из учения Мичурина — Лысенко, наследственные свойства не являются чем-то фатальным, а подвергаются изменениям под влиянием условий внешней среды. Наследственное предрасположение к болезни можно ослабить пп совсем устранить, воздействуя как на окружающую среду, так и ии самого человека. Поэтому лечение сводится к созданию нормальной среды, предупреждающей проявления экссудативного диатеза: правильный уход и воспитание, режим, соответствующее питание (см. *Питание детей*), витамины А, С, при показаниях и др. Недопущение перекормливания ребенка.

Питание матери (при экссудативных проявлениях у ребенка, находящегося на грудном вскармливании): исключить яйца, ограничить мясо, молоко, рекомендовать овощи и фрукты. В дальнейшем исключить из пищи ребенка вещества, к которым установлена повышенная чувствительность. Рекомендуется длительное пребывание на воздухе; при кожных поражениях добавлять к ваннам марганцовокислый калий, танин, крахмал (1 столовая ложка на ведро воды), череду (заварить 1 столовую ложку в стакане воды, затем процедить и вылить в ванну); при отсутствии кожных проявлений рекомендуется обтирание, массаж; желательны гимнастика, физкультура. Из медикаментов назначают препараты кальция, железа, витамины А (рыбий жир), С, более старшим детям — мышьяк. При пониженном аппетите дают соляную кислоту с пепсином и панкреатин.

**ДИСПЕПСИЯ ПРОСТАЯ ОСТРАЯ (DISPEPSIA SIMPLEX).** Причины — перекормливание, неправильное вскармливание, недокармливание; катарр верхних дыхательных путей, отит, пиелит и другие заболевания.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Частый стул, белиз и зеленые комочки, небольшая примесь слизи в испражнениях, отхождение газов, срыгивание, однократная рвота, пониженный аппетит, беспокойство. Остановка в нарастании веса или даже его падение.



Общее состояние мало нарушено, отсутствуют выраженные нарушения центральной нервной системы. Течение благоприятное у детей, развивающихся нормально, затяжное у детей с пониженным питанием.

**Л е ч е н и е .** Большое значение, согласно учению И. П. Павлова, придется организации окружающей среды, правильному чередованию периодов сна и бодрствования, достаточному пребыванию на свежем воздухе и правильной диетотерапии.

При диспепсии, вызванной недостатками вскармливания (перекормливание, введение пищи, не соответствующей возрасту), у детей, находящихся на грудном или смешанном вскармливании, пропускают 1—2 кормления, заменяя их жидкостью, в дальнейшем ограничивают количество пищи в течение 2—3 дней, назначая только грудное молоко. При диспепсии от недостатка молока у Матери докармливают женским сцеженным молоком или смесями. Искусственно вскармливаемым детям назначается на 10—12 часов водная диета: кипяченая вода, слабый чай, подслащенный сахаром, 5—10% раствор глюкозы, раствор Рингера, рисовый отвар. Всего жидкости за сутки из расчета 100 г на 1 кг веса. После водной диеты в случае отсутствия грудного молока назначают пахтанье или смесь из  $\frac{2}{3}$  молока и  $\frac{1}{3}$  рисового отвара 300—400 г в сутки; недостающее до нормы количество пищи заменяется жидкостью. Затем, постепенно увеличивая количество пищи, уменьшают количество жидкости. При диспепсии, сопутствующей инфекционным болезням, лечение основного заболевания и некоторое уменьшение общего количества пищи. Проведение водной диеты не всегда обязательно.

**П р о ф и л а к т и к а** см. *Диспепсия токсическая*.

**ДИСПЕПСИЯ ТОКСИЧЕСКАЯ (DYSPEPSIA TOXICA).** Часто наблюдается у ослабленных детей, находящихся на искусственном неправильном вскармливании, а также у перекормливаемых, особенно в летнее время.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Поражение нервной системы: вялость или возбуждение, чередование возбуждения и заторможенности, помрачение сознания, токсическое дыхание, вздутие легких, нарушение двигательной и тонической деятельности желудочно-кишечного тракта. Упорная рвота, учащенный жидкий стул. Обезвоживание организма: падение веса. Глухие тоны сердца. В моче белок, сахар, цилиндры. Течение тяжелое.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Надо исключить дизентерию, менингит, тяжелый пилзит, мастоидит.

**Л е ч е н и е .** При нарушении кортикальной деятельности — организация правильного режима, спокойная обстановка, способствующая удлинению физиологическому сну. Малые дозы препаратов брома. При сильном возбуждении — люминал, теплые ванны.

В первый день болезни полное лишение пищи и проведение водной диеты в продолжение 18—24 часов. Жидкость вводится часто, небольшими количествами (через 15—20 минут по 2—3 чайных ложки); при рвоте подкожно вводится раствор Рингера с 5% глюкозой или внутривенно вводится раствор Рингера с 20% глюкозой; внутримышечно вводится 10% раствор глюкозы. Внутривенное введение плазмы от 40 до 60 мл. Со второго дня дозированное дробное

кормление грудным сцеженным молоком, а недостающая до нормы (из расчета 110 мл на 1 кг веса) жидкость заменяется 5% раствором глюкозы, раствором Рингера, чаем, кипяченой водой с добавлением фруктовых соков, рисовым отваром. Схема кормления:

|      |      |                |             |             |                 |                                  |
|------|------|----------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| 1-й  | день | - 10 кормлений | по 10—20 мл | сцеженного  | молока          | +600—700 мл                      |
| 2-й  | »    | 10             | »           | от 20 до 30 | »               | » жидкости + 500-600 мл жидкости |
| 3-й  | »    | 10             | »           | > 30 » 40   | »               | » жидкости + 400-500 мл жидкости |
| 4-й  | »    | 10             | »           | » 40        | »               | » жидкости + 400 мл жидкости     |
| 5-й  | »    | 10             | »           | » 50-60     | »               | » жидкости + 300 мл жидкости     |
| 6-й  | »    | 8              | »           | по 70—80 мл | грудного молока |                                  |
| 7-й  | »    | 8              | »           | > 80-90     | »               | »                                |
| 8-й  | »    | 7              | »           | » 90-100    | »               | »                                |
| 9-й  | »    | 7              | »           | » 100—110   | »               | »                                |
| 10-й | я    | 0              | »           | » 120—130   | »               | »                                |

При улучшении общего состояния с 5—6-го дня ребенка прикладывают к груди на 5 минут. При отсутствии грудного молока после водной диеты применяют лечебные кислые смеси: пахтанье, подкисленную смесь,  $\frac{2}{3}$  молока и  $\frac{1}{3}$  рисового отвара, подкисленное снятое и цельное молоко, кефир. Когда количество принимаемой пищи будет доведено до 600—700 мл, прикорм увеличивают по обычным нормам кормления соответственно возрасту больного ребенка и в дальнейшем переводят на обычную пищу.

**Правильный уход.** Оберегать от охлаждения (грелка) и от перегрева, ухаживать за кожей, полостью рта (см. *Молочница*), глазами. Глаза промывать раствором Рингера. При частой упорной рвоте — промывание желудка 1—2% раствором соды или раствором Рингера.

**Синтомицин:** разовая доза 0,02 на 1 кг веса ребенка 4—5 раз в день в сахарном сиропе или стрептомицин внутрь 200 000—300 000 единиц, растворимый в 10 мл дистиллированной воды, в сутки по 1 чайной ложке 4 раза в день или сульфаниламидные препараты: сульфатиазол, сульфадимезин; суточная доза из расчета 0,2 на 1 кг веса равными приемами в течение суток (4—6 раз).

**Поливитаминотерапия:** аскорбиновая кислота 0,1 два раза в день, витамин В<sub>1</sub> 0,005 два раза в день.

В период выздоровления ферментотерапия — внутрь натуральный желудочный сок или соляная кислота с пепсином, панкреатин.

**Сердечные:** адреналин, коразол, кофеин, препараты дигиталиса.

В тяжелых случаях в период выздоровления — переливание крови по 30—50 мл через 4—5 дней повторно.

При осложнениях пневмонией, отитом и др. — подкожное введение пенициллина, альбомуцина.

**П р о ф и л а к т и к а .** Правильное вскармливание и уход за ребенком. Соблюдение санитарных правил в окружении ребенка.

P.p. T-rae Strophanthi 1,0  
 T-rae Valerianae simplicis 9,0  
 MDS. Но 3—5 капель 3 раза в день (грудной возраст) Rp.  
 Luminal i 0,015-0,02  
 Sacchari albi 0,3  
 M. f. p. D. t. d. N. 6  
 S. По 1 порошку 2 раза в день (грудной возраст) Rp.  
 Pepsini 1,0  
 Acidi hydrochloric! diluti 2,0  
 Aq. destill. 100,0  
 MDS. По 1 чайной ложке 3—4 раза в день перед едой  
 Rp. Pancreatini 0,15 Calcii carbonici 0,2 M. f. p. D. t. d.  
 N. 6 S. По 1 порошку 3—4 раза в день после еды  
 Rp. Sol. Natrii broniat 0,25 Aq. destill. 100,0  
 MDS. По 1 чайной ложке 3 раза в день

**ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ (ICTERUS NEONATORUM PHYSIOLOGICA).** Со второго дня жизни большинства новорожденных отмечается желтое окрашивание наружных покровов. Испражнения окрашены нормально, моча светлая, в ней нет желчных пигментов. Лечение не требует, проходит самостоятельно в конце первой или второй недели.

**ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННЫХ СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ (ICTERUS NEONATORUM SYMPTOMATICA).** Наблюдается при сепсисе, врожденном сифилисе, врожденном нарушении или полном отсутствии желчепроводящих путей, несовместимости группы крови матери и плода.

Для анализа необходимо обстоятельное клиническое обследование.

Лечение оспогшой болезни. \*

**ЗАПОРЫ (OBSTIPATIO).** Недостаточное или затрудненное испражнение. У детей первых месяцев жизни обычно при голодании (недостаток молока у матери, чрезмерно разведенное коровье молоко и т. д.) или нерациональное мигание с избыточным количеством коровьего молока. Наблюдается также у детей с вялой мускулатурой брюшной и кишечных стенок (атонические запоры), нередко при рахите, после острых желудочно-кишечных заболеваний. У детей более старшего возраста — при жидкой, протертой, бедной остатками пище. При нарушенных движениях кишечника ухудшается аппетит.

Лечение. Устранить основную причину: правильное и достаточное вскармливание (проверка количества грудного молока у матери путем взвешивания ребенка до и после кормления), уменьшение избыточных количеств коровьего молока за счет введения растительной пищи (овощей, фруктов, киселей) и более грубой пищи (черного хлеба, гречневой каши). При атонии кишечника — массаж живота, общеукрепляющее лечение. При очень крутых испражне-

ниях (овечий кал) — 1 чайная или десертная ложка вазелинового масла натошак. Частое применение клизм после 3 месяцев жизни не рекомендуется (во избежание привыкания). Необходимо приучить ребенка к регулярному опорожнению кишечника в определенное время с раннего детства. Слабительные не показаны. ЗАЯЧЬЯ ГУБА см. Врожденные пороки развития. КОЛИТ ОСТРЫЙ. Слизисто-кровянистый понос. См. главу II Инфекционные болезни. Дизентерия.

**КОЛИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (COLITIS CHRONICA).** Наблюдается после перенесенного острого колита. Чаще наблюдается у дистрофиков или ослабленных.

**Симптомы.\*** Учащенный до 3—5—8 раз в сутки жидкий, иногда со слизью, стул, часто обильный, с гнилостным запахом, иногда слабо окрашенный. Пониженное питание, увеличенный объем живота, бледность, вялость, иногда рвота, анемия, отсталость в развитии. Заболевание длительное, рецидивирующее.

**Распознавание** — исключить хроническую дизентерию. **Лечение.** Правильный режим. Регулярное пребывание на свежем воздухе. Массаж. Гимнастика. Полноценное питание: кефир, творог, шоре из овощей, мясо. Аскорбиновая кислота (витамин С) по 100—200 мг ежедневно, витамин В<sub>12</sub>, никотиновая кислота, натуральный желудочный сок, соляная кислота с пепсином, панкреатин, углекислый кальций, облучение ртутно-кварцевой лампой, массаж. Инсулин, переливание крови. В период обострения — сульфаниламидные препараты, антибиотики — синтомицин, левомице-тип, стрептомицин, иногда вяжущие и дезинфицирующие средства (таннальбин, висмут, салол).

**Профилактика.** Правильное лечение острого инфекционного колита, предохранение от инфекции. Установление правильного режима.

**КРОВАВАЯ РВОТА НОВОРОЖДЕННЫХ (MELAENA NEONATORUM).** МЕЛЕНА. Возникает вследствие кровоизлияния из слизистой желудка и кишок.

**Симптомы.** Кровавая рвота, иногда обильная, испражнения темнокрасного цвета, общая вялость, падение в весе. Развивается тяжелое малокровие.

**Лечение.** Витамин К по 0,005 три раза в день в течение 5 дней; 5% раствор хлористого кальция по 1 чайной ложке 6 раз в сутки; переливание крови по 30—40 мл, полный покой; кормление охлажденным женским молоком малыми порциями.

**КРОВОИЗЛИЯНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ.** Причина — тяжелые, а иногда и неправильно проведенные роды, особенно часто у недоношенных детей.

**Симптомы.** Беспокойство или сонливость, судороги, расстройство глотания и сосания, повышение температуры на 3—4-й день жизни, приступы асфиксии, нистагм, косоглазие.

**Лечение.** Полный покой, тщательное согревание, осторожное кормление, кислород; при судорогах — хлоралгидрат. Внутримышечно — материнская кровь 5 мл. Витамин К внутрь по 5 мг 1—2 раза в день. Аскорбиновая кислота (витамин С) по 50 мг 1—2 раза в день.



Rp. Chlorali hydrali 0,3 Decocti Salep 30,0 MDS.

На одну клизму новорожденному

### ЛАРИНГИТ ОСТРЫЙ см. Ложный круп.

**ЛОЖНЫЙ КРУП. ЛАРИНГИТ ОСТРЫЙ.** Частое заболевание у детей в возрасте от 2 до 5 лет. Возникает как осложнение острого катарра дыхательных путей, как предвестник кори или в катарральном периоде коклюша.

**Симптомы и течение.** Внезапное начало, повышение температуры, насморк, лающий мучительный кашель при неизменном голосе, одышка с затруднением вдоха. Общее состояние напоминает дифтерийный стеноз гортани. Предсказание хорошее.

**Распознавание.** Внезапное начало, быстрое улучшение состояния под влиянием принятых мер. Исключить дифтерию гортани (истинный круп), при которой стеноз развивается медленно, в течение 2—3 дней, и сопровождается изменением голоса вплоть до афонии.

**Лечение.** Теплое питье, паровая ингаляция, горчичник на область гортани и трахеи, горячая ванна (ножная или общая), отхаркивающие лекарства. Если не наступает быстрого улучшения, необходимо вводить противодифтерийную сыворотку.

Rp. Inf. rad. Ipecacuanhae ex 0,2 : 100,0

S. По 1 чайной или десертной ложке через 4 часа

Rp. Inf. rad. Senegae ex 2,0 : 100,0

S. По 1 чайной ложке через 4 часа

Rp. Liq. Ammonii anisati

■ Natrii benzoici aa 2,0 Aq. destill. 100,0 MDS. По 1 чайной или десертной ложке через 4 часа

**МЕЛЕНА** см. *Кровавая рвота новорожденных.* \*

**МОЛОЧНИЦА (SOOR).** Вызывается грибом *Monilia albicans*. Легко развивается у детей первых недель жизни, а у более старших — при нарушениях питания, снижении иммунитета.

**Симптомы и течение.** Плотнo сидящие на покрасневшей слизистой рта белые бляшки, похожие на свернувшееся молоко. В тяжелых случаях бляшки распространяются на слизистую пищевода и дыхательных путей.

**Лечение.** Осторожное смазывание пораженных мест раствором буры в глицерине (Boracis 4,0 + Glycerini 20,0) или концентрированным сахарным сиропом несколько раз в день перед кормлением. Частое орошение рта из пипетки 1—2% содовым раствором. После кормления давать по 1 чайной ложке 1% содового раствора.

**Профилактика.** Соблюдение чистоты при уходе за ребенком (частое мытье рук, обмывание грудной железы перед кормлением, кипячение бутылочек, сосок и т. д.); не следует протирать рот ребенка.

### НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ

Дети, родившиеся до истечения нормального срока беременности. Вес от 1 000 до 2 500 г, рост ниже 45 см.

**Причина** — заболевание матери: многоплодная беременность, травмы и др.

**Симптомы.** Обильная волосатость по всему телу, слабое развитие подкожножирового слоя, зияние половой щели у девочек, отсутствие яичек в мошонке, мягкость ушных хрящей, деформация ушных раковин, неспособность регулировать температуру тела, склонность к расстройству дыхания — вторичной асфиксии, отсутствие сосательного, а иногда и глотательного рефлекса.

**Уход и кормление.** Усиленное согревание (обкладывание грелками с трех сторон тщательно укутанного ребенка — открытым остается только лицо), температура комнаты 20—24°, температура воды в грелке 65—70°. Высокое изголовье, 0,5% рас-, твор кофеина внутрь по 1 чайной ложке 3—4 раза в сутки, вдыхание кислорода до и после каждого кормления. Кормить через 3 часа 7 раз в сутки детей с весом свыше 1 000 г и через 2V<sub>2</sub> часа — 8 раз в сутки с более низким весом. 5—10% раствор глюкозы на физиологическом растворе по 40,0—60,0 мл в сутки, витамин С 0,025—0,05 в сутки.

При отсутствии глотательного рефлекса кормить с помощью пипетки или ложечкой через нос (накапывая молоко у носового хода). После появления глотания кормить через Н-шадку, сцеживая в нее молоко, после появления активного сосания приложить к груди. Суточное количество молока V<sub>6</sub> веса.

Ванны — ежедневно после отпадения пуповины, температура воды 38—40°, в зависимости от веса.

Прогулка на воздухе с на-ала 2-го месяца жизни с 5—10 минут при постепенном удлинении ее до 1/2 часов 2 раза в день. Тщательное ограждение от контакта с посторонними как взрослыми, так и детьми.

На 2-м месяце выкладывание ребенка на живот 3 раза в день по 1—2 минуты для профилактики пупочной грыжи.

Стимуляция двигательных движений путем ежедневной гимнастики, начиная с 3—4-месячного возраста.

Профилактика рахита с первого месяца жизни (30 000 единиц витамина D<sub>3</sub> в течение 12—14 дней) или облучение кварцем 12—15 сеансов, начиная с V<sub>4</sub> биодозы до 4 биодоз.

Недоношенных необходимо задерживать в родильном доме не менее 12—15 дней.

При правильном уходе недоношенные Дети догоняют доношен-ных к концу первого года жизни по всем показателям развития.

**ОПРЕЛОСТЬ (INTERTRIGO).** Покраснение кожи и последующее шелушение. Зависит в основном от плохого ухода, недостаточно частого пеленания днем и ночью. Иногда это ранний симптом экссу-дative диатеза или врожденного сифилиса.

**Лечение.** Пеленать до кормления и через час после него хо-рошо постиранными, высушенными и проглаженными горячим утюгом пеленками. Защищать кожу от мочи и испражнений, смазывая ее вазелиновым или подсолнечным (растительны,!) маслом,

борной или другой индифферентной мазью. Обнажать опрелые места (воздушные ванны) 3 раза в день по 5 минут.

Rp. 01. Camphorati 6,0  
Zinci oxydati Vaselini  
aa 10,0 M. f. ung.  
DS. Мазь

**ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ, ПЛЕЧЕВОЙ И БЕДРЕННОЙ КОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ.** Встречаются при неудачном родоразрешении (у каждого новорожденного следует ощупывать все кости!). Перелом определяется по измепению очертания и формы кости, по болезненности и хрусту.

**Лечение.** При переломе плечевой и бедренной кости наложение шины или гипсовой повязки, придав обломкам правильное положение (проверить рентгеновским снимком). При переломах ключицы лечения в большинстве случаев не требуется.

**ПИЛОРОСТЕНОЗ.** Врожденный порок развития — гипертрофия привратника вследствие избыточного роста кольцевой мускулатуры, что приводит к сужению привратника.

**Симптомы.** Характерный симптом — рвота, отличающаяся упорством и интенсивностью; появляется в конце второй или начале третьей недели жизни. Рвота бывает после каждого приема пищи непосредственно или с определенным промежутком. Аппетит хороший. Во время кормления или после него отмечается беспокойство: ребенок плачет, кричит, как бы испытывает боль, которая проходит после рвоты. Характерным для этого состояния является видимая перистальтика желудка или других отделов кишечника. Вскоре после кормления или при охлаждении живота (распеленать ребенка) или при легком ощупывании заметно движение перистальтической волны, идущей от левого подреберья вправо: то видна одна волна, то одна волна следует за другой. При следующих друг за другом волнах желудок представляется в виде двух полушарий, разделенных бороздкой, — песочные часы; иногда желудок имеет форму тара. При прощупывании под краем печени можно отметить опухоль хрящевой консистенции — сокращенный гипертрофический привратник. Желудок расширен. Нижняя граница доходит до пупка или даже ниже. Запоры. Стул не обильный, темного цвета, с примесью слизи — голодный стул. Мочеиспускание редкое. Частая рвота приводит к голоданию организма, а в дальнейшем к гипотрофии. Вес детей падает и в возрасте 1 1/4—2 месяцев они весят меньше, чем при рождении.

**Диагностика** устанавливается на основании картины болезни, рентгеноскопии и рентгенографии: замедленное опорожнение желудка, глубокие перистальтические сокращения. В нормальных условиях через 3—4 часа желудок обычно бывает пуст. При пилоростенозе контрастные массы могут задержаться в желудке до 24 часов.

**Лечение.** Операция, заключающаяся в рассечении стенки привратника вплоть до подслизистой оболочки без последующего вашивания; правильное питание.

**ПИЛОРОСПАЗМ.** Спазм привратника. Характерным симптомом является рвота. Она обычно начинается с рождения, не тая постоянна, как при пилоростенозе, и не приводит ребенка к глубокому истощению. Обычно в возрасте 1 1/2—2 месяцев в противоположность пилоростенозу ребенок весит больше первоначального веса при рождении. Перистальтические волны либо не отмечаются совсем, либо бывают значительно реже. Рентгенологически не отмечается задержки контрастной смеси в желудке. В основе рвоты при пилороспазме лежит недостаточная зрелость центральной нервной системы, особенно ее вегетативного отдела, и повышенная возбудимость, вызывающая рефлекторно спазмы привратника. В возрасте 3—4 месяцев этот дефект устраняется.

**Лечение.** Давать прикорм к грудному молоку, к 4—5-му кормлению, по 1 чайной ложке 10% манной каши (до кормления), введение жидкости (5% глюкозы, физиологического или рингеровского раствора через рот и клизмы); горчичник с двухкопеечную монету на подложечную область в течение нескольких дней по 5 минут. Промывание желудка, в особенности при большом количестве слизи в рвотных массах, Sol. Atropini sulfurici 1 : 2 000 оз 4 до 6 капель перед кормлением 3—4 раза в день или Sol. Adrenalin! 1 : 1 000 подкожно по 0,2 мл 2—3 раза в день.

**ПИЭЛИТ (ПИУРИЯ) (PYELITIS). ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК.** Сопутствует различным инфекционным болезням, в частности, острому катарру верхних дыхательных путей, заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Редко как самостоятельное заболевание. При остром течении: тяжелые нарушения со стороны центральной нервной системы, судороги у детей раннего возраста, рвота, температура до 39—40°, боли в пояснице (положительный симптом Пастернацкого) и при мочеиспускании, учащенный стул, отсутствие аппетита, вялость, бледность.

При подостром течении: температура субфебрильная, у ослабленных детей даже нормальная; пиэлит ухудшает течение основного заболевания. В моче незначительное количество белка, но много лейкоцитов. Болезнь имеет склонность рецидивировать.

**Лечение.** Правильный гигиенический режим, рациональное питание, введение достаточного количества витаминов. При обострении — постельный режим, обильное питье, сахарно-фруктовые дни. Горячие ванны. Медикаментозное лечение, сульфаниламидные препараты (сульфадимезин, сульфатиазол) по 0,3—0,5 четыре-пять раз в день. Пенициллин внутримышечно по 100 000—200 000 единиц в день. Уротропин внутрь: 0,2—0,3 три раза в день.

Rp. Urotropini 2,0  
Coffeini natrio-salicylici 0,6  
Aq. destill. 100,0  
Sir. corticis Aurantii 20,0  
MDS. Но 1 чайной (десертной) ложке 3 раза в день

**ПЛЕВРИТ ГНОЙНЫЙ. ЭМПИЕМА (PLEURITIS PUBULEN-TA, EMPiEMA).** Осложнение пневмонии. Возбудители пневмококк, реже стрептококк, стафилококк и смешанная инфекция.

**Симптомы и течение.** Высокая температура, общее тяжелое состояние, одышка, смещение органов — сердца, печени. Значительное притупление перкуторного звука и резко ослабленное дыхание. По мере увеличения выпота в полости плевры нарастает тупость, смещение органов и появляется треугольник Раухфуса (треугольник притупления перкуторного звука на здоровой стороне у позвоночника). Диагноз подтверждается проколом плевры, который производится 10—20-граммовым шприцем сзади по лопаточной линии или задней подмышечной линии между VII и VIII ребром, желательнее на месте наибольшей тупости. Гнойный плеврит у детей часто осложняется самостоятельным пневмотораксом вследствие прорыва легочной ткани в полость плевры. Наличие в полости плевры воздуха и гноя вызывает еще большее смещение органов, но не оказывает особого влияния на дальнейшее течение воспалительного процесса. По мере удаления гноя из полости плевры имеющийся там воздух всасывается, и наступает расправление легочной ткани.

**Лечение.** Отсасывание гноя из плевры по 100—200 мл через день и реже; одновременно вводится при каждом проколе 50 000—100 000 единиц пенициллина в 30—40 мл физиологического раствора; пенициллин впрыскивается также внутримышечно 2—3 раза в 0,5% растворе новокаина в количестве 100 000—200 000 единиц в сутки. Укрепляющее лечение: препараты железа, кальция, рыбий жир, витамины, повторное переливание крови.

При отсутствии эффекта от этого лечения — хирургическое вмешательство.

В период выздоровления — дыхательная гимнастика, длительное пребывание на свежем воздухе и полноценное питание с добавочным введением витаминов.

**ПНЕВМОНИЯ МЕЛКОГНЕЗДНАЯ (БРОНХОПНЕВМОНИЯ МЕЛКООЧАГОВАЯ КАТАРАЛЬНАЯ).** Наиболее частая форма острого воспалительного процесса в легких у детей в возрасте до 2 лет. Часто возникает как осложнение гриппа, бронхита, кори и коклюша и реже — среди полного здоровья как острое заболевание.

Частый возбудитель мелкогнездной пневмонии — пневмококк (70—100%), реже — стрептококк, стафилококк, бацилла Фридлен-дера и др.

**Симптомы и течение.** Постепенное начало заболевания, повышенная температура 38—39°, учащенное, поверхностное дыхание. Раздувание крыльев носа, втяжение межреберных промежутков и диафрагмы, цианоз, кашель, ухудшение общего состояния, понижение аппетита, поражение нервной системы. Общие токсические явления и явления кислородной недостаточности появляются нередко еще до развития воспалительных очагов в легочной ткани. Перкуторно отмечается тимпанический оттенок звука в передних отделах и приглушение перкуторного звука в задне-нижних отделах. При аускультации — большое количество мелкопузырчатых влажных хрипов, а при слиянии отдельных мелких очагов и образовании крупных очагов — бронхофония, бронхиальное дыхание, крепитирующие хрипы.

Топы сердца приглушены, пульс учащен, плохого наполнения. В тяжелых случаях сердце расширено вправо. Печень увеличена. Ребенок часто бывает возбужденным, отказывается от груди. Временами затемняется сознание. Могут быть рвоты, судорожные подергивания.

Иногда развиваются осложнения со стороны плевры и ушей, возникают хронические пневмонии.

У ослабленных детей с пониженным питанием нередко затяжное и рецидивирующее течение с исходом в хроническую интерстициальную пневмонию.

**Распознавание.** Необходимо исключить бронхит, бронхиальную астму, диспепсию с токсикозом, а при затянувшемся течении — туберкулезное поражение легких (при помощи туберкулиновых проб и рентгенологического исследования).

**Профилактика пневмоний.** Правильный режим, грудное вскармливание со своевременным введением прикорма, систематические ежедневные прогулки на свежем воздухе, тщательное проветривание помещения, в котором находится ребенок. Закаливание ребенка. Профилактика рахита. Оберегание ребенка от заболевания гриппом, корью, коклюшем.

**Лечение.** Необходима ранняя диагностика и своевременное лечение, желательнее в больничной обстановке.

Основное значение имеет правильная организация внешней среды с широким пользованием свежим воздухом, хорошим уходом и полноценным питанием, добавочным введением витаминов. Кроме того, назначаются горячие ванны, горчичные обертывания, диатермия. Тотчас по установлении диагноза назначаются сульфаниламидные препараты (сульфидин, сульфазол, сульфатиазол, сульфа-диамезип и др.) 5 раз в сутки. Дозы см. *Дозировка лекарственных средств*, гл. *Фармакологические свесния*.

После установления нормальной температуры и улучшения общего состояния сульфаниламидные препараты необходимо давать не менее 3 дней.

При тяжелом течении пневмонии у детей первых месяцев жизни одновременно с сульфаниламидными препаратами проводится введение пенициллина по 100 000—200 000 единиц в сутки внутримышечно или альбумидин и применяется стимулирующая терапия — гемотерапия, переливание плазмы или крови внутривенно (по 25—50 мл через 4—5 дней повторно).

По показаниям: сердечные средства, глюкоза, кислород, лекарства, успокаивающие кашель, и т. д.

Rp. Sol. Adrenalini hydrochlorici (1 : 1 000) 1,0 in amp.  
D. t. d. N. 6 S. По 0,2—0,3—0,5 мл на инъекцию

Rp. Ephedrini 0,005—0,025 (в зависимости от возраста)  
Sacchari albi 0,2  
M. f. p. D. t. d. N. 12  
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Pr. Sol. Coffeini natrio-benzoici 10% 1,0 in amp.  
S. По 0,5—1 мл на инъекцию

Rp. T-rae Strophanthi 1,0  
T-rae Valerianae simplicis 9,0  
MDS. По 5—10 капель 2—3 раза в день

Pr. Gitaleni 5,0  
DS. По 3—5 капель 2—3 раза в день

Rp. Sol. Glucosi 10% 200,0  
DS. По 1 чайной ложке через 15—20 минут

Rp. Sol. Glucosi 10% £0,0 Sterilisetur! S. Для  
внутримышечного введения

Rp. Sol. Glucosi 20% 20,0 Sterilisetur! S.  
Для внутривенного введения

**ПНЕВМОНИЯ КРУПЗНАЯ (PNEUMONIA CRUPOSA). ДО-  
ЛЕВАЯ КРУПНООЧАГОВАЯ.** Фокальная долевая, крупноочаговая  
пневмония, главным образом у детей старте 1 года, в единичных  
случаях у детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года.

**Симптомы и течение.** Острое начало заболевания,  
высокая температура в пределах 39—40°, циклическое течение со  
снижением температуры на 5—8—10-й день. В легких выраженный  
массивный воспалительный процесс, занимающий часть доли легкого  
или же целую долю. Нарушение общего состояния и одышка менее  
выражены, чем при мелкоочаговой пневмонии.

С 1-го дня заболевания приглушение перкуторного звука, брон-  
хофония, В последующие дни на месте притупления выслушивается  
бронхиальное дыхание и единичные трескучие хрипы, увеличиваю-  
щиеся с 4—5-го дня. Локализация воспаления чаще в нижней доле  
левого легкого, затем в нижней и верхней доле правого легкого.  
Средняя доля правого легкого и верхняя доля левого поражаются редко.  
При локализации воспалительного процесса в верхней доле правого  
легкого с первых дней заболевания часто наблюдается потеря сознания,  
рвота и судороги.

Несмотря на бурное начало заболевания,— благоприятное тече-ние  
и полное выздоровление в дальнейшем. Осложнения развиваются  
редко.

**Распознавание.** Острое начало, циклическое течение,  
наличие одного очага в легочной ткани. Исключить цереброспиналь-  
ный менингит, аппендицит, брюшной тиф, туберкулезный инфильтрат  
в легком.

**Профилактика и лечение** см. *Пневмония мелко-  
очаговая.*

**ПНЕВМОНИЯ ХРОНИЧЕСКАЯ (ХРОНИЧЕСКАЯ ИНТЕР-  
СТИЦИАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ, БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ  
БОЛЕЗНЬ, ПНЕВМОСКЛЕРОЗ).** Развивается постепенно после  
многих повторных пневмоний у детей с пониженным питанием, ши-

вущих в неадаптированных условиях, или перенесших повторные  
заболевания органов дыхания, грипп, корь и коклюш. Имеет значение  
также аспирация инородного тела в бронхи и легочную ткань,  
врожденные пороки сердца и ревматическая инфекция, бронхиальная  
астма; поражение придаточных полостей носа.

**Симптомы и течение.** Общее недомогание, плохое  
нарастание в весе и слабое физическое развитие; периоды обострения  
воспалительных явлений в легких чередуются с периодами затишья;  
временами повышение температуры. Постепенно образуются ногти в  
виде часовых стекол, пальцы в виде барабанных палочек, постоянный  
кашель с выделением гнойной мокроты, запах изо рта, увеличение  
грудных лимфатических узлов на стороне поражения, увеличение  
печени. Заболевание прогрессирует постепенно, происходит  
уплотнение стенок бронхов, их расширение, разрастание  
соединительной ткани в легких и занустванию легочных пузырьков.

**Распознавание.** Анамнез — перенесенные повторные  
пневмонии, длительность заболевания. Необратимые изменения в  
легочной ткани при отрицательных туберкулиновых пробах и от-  
сутствие контакта с туберкулезными больными позволяют отграничить  
от туберкулеза легких. В сомнительных случаях — повторное  
исследование мокроты и промывных вод из желудка на туберкулезную  
палочку.

**Профилактика.** Раннее распознавание острых пневмоний,  
тщательное лечение их вплоть до полного рассасывания воспали-  
тельного процесса в легких. Общее укрепляющее лечение и повышение  
сопротивляемости организма ребенка в период выздоровления.

**Лечение.** В период обострений — применение комплексного  
лечения сульфаниламидными препаратами, пенициллином, альбому-  
цином; переливание крови, как при острых пневмониях. В периоды  
затишья процесса — лечебная физкультура с дыхательной гимнасти-  
кой, пребывание на свежем воздухе и общеукрепляющее лечение.

**ПНЕВМОНИЯ МЕЖУТОЧНАЯ (ОСТРАЯ ИНТЕРСТИЦИАЛЬ-  
НАЯ).** Возникает среди полного здоровья или как осложнение сепсиса  
у новорожденных. Возбудитель — вирус, проникающий в Легкие  
бронхогенным путем, но инфицирование может происходить и по  
кровеносному руслу.

**Симптомы и течение.** Ухудшение общего состояния,  
повышение температуры, появление резко выраженного цианоза,  
частый кашель при отсутствии хрипов в легких и притупления пер-  
куторного звука. Длительность 2—3 недели, заканчивается благо-  
приятно.\*

**Распознавание.** Необходимо исключить обычную мел-  
коочаговую пневмонию, милиарный туберкулез, врожденный порок  
сердца.

**Лечение.** Усиленное пользование свежим воздухом, повы-  
шение сопротивляемости организма ребенка введением витаминов,  
глюкозы, переливанием плазмы и крови. Лечение сульфаниламидными  
препаратами и пенициллином неэффективно в отношении вирусной  
инфекции, но предупреждает развитие осложнений и вторичной  
кокковой инфекции.

Пупка заболевания. **Пупочный грибок** (*fungus umbilici*). Пупочная ранка не заживает больше 2 недель и мокнет. При осмотре на дне ее избыточные грануляции. Смазывание палочкой ляписа. Если грануляции на ножке, перевязать стерильной шелковой ниткой. Наложить повязку со стерильным вазелиновым маслом.

Флегмона пупка (*phlegmona umbilici*). Припухлость, инфильтрат, отечность в окружности пупка, краснота и болезненность; повышение температуры и ухудшение общего состояния.

При каждом заболевании пупочной ранки есть опасность проникновения инфекции в брюшину или пупочные сосуды. Последствие — сепсис.

**Профилактика.** Строгая асептика при уходе за пуповиной и пупочной ранкой, начиная с момента родов и до зарубцевания пупочной ранки.

**Лечение** гнойных поражений пупочной ранки: промывание перекисью водорода, спиртовая повязка, стрептоцид для присыпки и внутрь по 0,1 два-три раза в день, при флегмоне — хирургическое лечение, пенициллин по 500 000—1 000 000 единиц в сутки равными частями через 4 часа или 2 раза с 0,5% раствором новокаина.

Язва пупка (*ulcus umbilici*). Окружность пупочной ранки припухшая, дно ее изъязвлено. Если есть налет на ранке, обязательно исследовать его на дифтерию. При положительных находках — введение противодифтерийной сыворотки. При отрицательном результате лечение такое же, как при флегмоне.

**РАХИТ (RACHITIS).** Недостаточное поступление или использование витамина D в организме ребенка. Развитию рахита способствует искусственное, неправильное вскармливание, несвоевременный и нерациональный прикорм, недостаточное пользование воздухом, повторные инфекционные болезни. У недоношенных детей рахит развивается чаще и раньше, чем у доношенных.

**Симптомы и течение.** Раньше всего при рахите появляются нарушения со стороны нервной системы: раздражительность, беспокойный сон, потливость, особенно затылка, зуд.

На 3—4-м месяце жизни появляются и костные изменения в виде размягчения костей черепа в области боковых родничков. Несколько позднее — лобные и теменные бугры. В дальнейшем наблюдаются утолщения на месте перехода костной части ребра в хрящевую, сдавленно грудной клетки с боков (куриная грудь), развороченные в стороны нижние края грудной клетки. На нижних концах предплечья появляются утолщения (браслетки), иногда видимые на глаз, иногда обнаруживаемые только при ощупывании; искривления костей верхних, особенно нижних конечностей, и поясничного отдела позвоночника (рахитический юрб). Запоздывает закрытие родничка и появление зубов, нарушается порядок их прорезывания. Одновременно с костными изменениями наблюдается гипотония мышц, разболтанность суставов, увеличение печени и селезенки, малокровие. Ребенок поздно начинает сидеть, стоять, ходить, говорить. У больных рахитом часто бронхиты, тяжелое течение пневмоний.

**Лечение.** Назначение витамина D, рыбий жир, который дается детям 3—4 месяцев по 1 чайной ложке 2—3 раза в день и

»

течение 2—3—4 месяцев подряд, правильный режим и питание, физиотерапия.

Витамин D выпускается в масляном растворе в двух концентрациях: в первом содержится 10 000 единиц в 1 мл масла, а во втором в 1 мл масла 30 000 единиц, т. е. 1 000 единиц содержится в 3 каплях первого препарата и в одной капле второго (в 1 мл масла 32 капли). Лечебная доза определяется в зависимости от степени рахита, от (1 000 до 10 000 единиц в день. При рахите средней тяжести дают по 10 капель два раза в день первого препарата или по 3 капли второго в течение месяца; после перерыва в 2—3 недели курс лечения повторяют. В более тяжелых случаях выгоднее проводить лечение массивными дозами в < более короткий срок — по 30 000 единиц ежедневно в течение 10 дней; после перерыва в 3 недели курс лечения повторяется.

В острых случаях рахита, а также при неустойчивом стуле можно давать спиртовой раствор витамина D, содержащий 200 000 единиц в 1 мл (65 капель).

Облучение ультрафиолетовыми лучами — ртутно-кварцевой лампой, начиная с 2—3 минут на расстоянии 50—100 см от горелки, доводя длительность сеанса до 10—15 минут и уменьшая расстояние до 50—70 см. Всего проводят 15—20 сеансов; если нужно, курс лечения повторяют через 2—3—4 недели. При туберкулезе облучение противопоказано.

Одновременно с введением витамина D необходимо проводить правильный режим с максимальным пользованием свежим воздухом. Ребенок должен получать полноценное питание, соответствующее его возрасту, витамин А, витамины группы В и витамин С, в присутствии которых действие витамина D более эффективно.

**Профилактика.** Начинается во время беременности. Пища беременной должна содержать достаточное количество солей (овощи) и продуктов, богатых витамином D. Беременная должна много бывать на солнце, а в последние месяцы беременности (зимой) рекомендуется проводить курс облучения ультрафиолетовыми лучами, принимать рыбий жир или витамин D и > 5 000—10 000 единиц в день. Ребенку, родившемуся осенью или зимой, а также искусственно вскармливаемому, начиная с 3 месяцев от рождения нужно давать рыбий жир по 1 чайной ложке в день или витамин D по 2 000—4 000 единиц в день в течение всей зимы, или подвергать облучению ультрафиолетовыми лучами (10—15 сеансов). Недоношенному ребенку профилактическое введение витамина D в том или другом виде надо начинать уже с IV-го месяца.

В зимнее время года профилактике подлежат все дети первого и второго года жизни.

**СПАЗМОФИЛИЯ.** Детская тетания — повышенная возбудимость нервной системы, сопровождающаяся расстройством солевого (минерального) обмена. По своим причинам связана с рахитом (см. *Rachitis*). Наблюдается главным образом в зимне-весенние месяцы у детей раннего возраста, больных рахитом.

**Симптомы и течение.** — С п а з м о ф и л и я я в н а я — спазм мышц голосовой щели — ларингоспазм рвильной тяжести: от затрудненного вдоха до остановки дыхания, сопровождающейся

цианозом, холодным потом. Спазм мышц конечностей, главным образом кистей и стоп. При длительном спазме отечность на тыльной стороне кистей и стоп. При тяжелой форме общие судороги с потерей сознания, высокой температурой, пеной изо рта, холодным потом. С п а з м о ф и л и я с к р ы т а я встречается чаще. Но обнаруживается при обычном клиническом осмотре. Только специальное обследование, указывающее на повышенную механическую возбудимость периферических нервов (поколачивание пальцем немного ниже скуловой дуги, вызывающее подергивание в шикнем и верхнем веке и др.), выявляет эту форму спазмофилии. Выявляется также в виде общих судорог при высокой температуре в течение различных заболеваний. При правильном лечении исход благоприятный.

Р а с п о з н а в а н и е. Производится на основании анамнеза и типичной клинической картины. Для исключения судорог при органических заболеваниях центральной нервной системы необходимо детальное неврологическое исследование. Для исключения эпилепсии требуется иногда длительное наблюдение.

Л е ч е н и е и п р о ф и л а к т и к а (см. *Профилактика и лечение рахита*). Начинать с кратковременного лишения пищи (8—12 часов), давать обильное питье, на несколько дней исключить из рациона или ограничить коровье молоко. Пища, содержащая большое количество углеводов с большим количеством овощных соков. Создавать вокруг ребенка спокойную обстановку, стремиться удлинить физиологический сон. Препараты кальция, рыбий жир, витамин D.

Во время приступа ларингоспазма — широкий доступ холодного свежего воздуха, делать искусственное дыхание. Против судорог применяется хлоралгидрат, люминал, препараты брома; внутримышечно Sol. Magnesium sulfurici 5% по 0,2 мл на 1 кг веса ребенка. По показаниям — люмбальная пункция.

- Нр. Calcii chlorati icci 20,0  
Mucilaginis Salepi 30,0  
Siropus simplicis 20,0 \*  
Аq. destill. 150,0 MDS. По десертной ложке 4—5 раз в день после еды
- Рр. Calcii gluconici 25,0  
DS. По V<sub>4</sub>—V<sub>2</sub> чайной ложки 3—4 раз в день
- Рр. Chlorali hydrati 0,5—1,0 Decocti  
Amyli tritici 60,0 MDS. На 2 клизмы
- Рр. Luminali 0,01—0,03 Sacchari albi 0,3  
D. t. d. N. 6 S. По 1 порошку 2 раза в день

СЕПСИС НОВОРОЖДЕННЫХ (SEPSIS NEONATORUM). Общее заражение гноеродными и другими бактериями.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Падение в весе, бледносерая или желтушная окраска кожи, понижение аппетита (отказ от груди), рвота, понос, глухость тонов сердца, токсикоз, часто повыше-чая температура; увеличение печени и с(лезенки. Изредка мелкоточечные кровоизлияния па коже, беспокойство или вялость. Возможны метастазы: в легкие, почки, мозговые оболочки и т. д. (сеп-тикопиемия). Заболевание тяжелое. Протекает нередко с осложнением: отиты, пневмонии. Кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, желтуха, беспокойство или вялость, рвота, понос. Заболевание тяжелое. Инфекция может проникнуть через кожу и слизистые оболочки. Исход зависит от своевременного, правильного лечения, вскармливания и ухода.

Л е ч е н и е. При первых местных признаках одновременное лечение пенициллином и сульфаниламидными препаратами; организация наилучшего ухода и грудного вскармливания. Сульфаниламидные препараты — в количестве 0,2 на 1 кг веса, 5 раз в день, через 4 часа, ночью перерыв; пенициллин 100 000—200 000 единиц в сутки на три инъекции. Вводится в 0,5% растворе новокаина или 1% раствор.: пирамидона. Местные воспалительные очаги лечат по соответствующим правилам.

П р о ф и л а к т и к а. Строгая асептика и антисептика в родильной палате и при уходе за новорожденным. Своевременное лечение беременных при наличии у них воспалительных гнойных процессов. Изоляция больных матерей и детей. Работа врачей, акушеров и сестер в масках.

СТРИДОР ВРОЖДЕННЫЙ. Врожденное нарушение дыхания, зависящее от недоразвития надгортанника или гортани или нарушения иннервации гортанной мускулатуры.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Затрудненное дыхание с шумным вдохом при нормальном выдохе и чистом голосе, напоминающее кудахтанье курицы или «укаиье»; при общем хорошем состоянии ребенка стридор появляется тотчас после рождения, постепенно ослабевает со второго полугодия и совершенно исчезает на втором, третьем году жизни.

Р а с п о з н а в а н и е. Ранний возраст и характер шума исключают сдавление гортани увеличенной зубной и другими железами.

Лечение обычно не требуется.

ТУБЕРКУЛЕЗ (TUBERCULOSIS). Ребенок заражается обычно после рождения. Основным источником заражения является мокрота больного туберкулезом. Заражение чаще всего происходит через дыхательные пути, но может проиаойти и через желудочно-кишечный тракт.

Методы выявления туберкулеза: 1) туберкулиновые пробы Пирке и Манту; 2) физические методы исследования; 3) рентгенологическое исследование (наиболее совершенный метод для раннего выявления локализации и характера заболевания); для выявления рассеянных форм необходима рентгенография; 4) бактериологическое исследование.

Бронхаденит туиеркулезный. Возбудитель в большинстве случаев внедряется в легкие. На месте внедрения образуется



туберкулезный очаг, откуда затем инфекция проникает в ближайшие бронхиальные лимфатические узлы.

Различают туморозный и инфильтративный бронхаденит.

Туморозный бронхаденит. Часто наблюдается у маленьких детей. Признаки: с давлением трахеи увеличенными узлами, коклюшеподобный кашель со звонким металлическим оттенком, шумное, затрудненное дыхание, повышение температуры, беспокойство, вялость, раздражительность, плохой сон и аппетит, плохое нарастание в весе. Течение часто неблагоприятное (развитие милиарного туберкулеза и туберкулезного менингита).

Инфильтративный бронхаденит. Обычно встречается у детей старшего возраста.

**Симптомы и течение.** Температура вначале часто высокая, затем снижается и может долго оставаться субфебрильной. Общее состояние нарушается: плохой аппетит, раздражительность, вялость, часто плохой сон, снижение в весе. Течение благоприятное, но по временам наблюдаются обострения. Процесс часто подвергается обратному развитию, в узлах развивается соединительная ткань и откладывается известь. Бронхадениты могут давать вспышки, в результате чего иногда возникает милиарный туберкулез и туберкулезный менингит.

**Лечение.** Гигиено-диететическое, санаторное. В период обострения — лечение антибиотиками (ПАСК) и в тяжелых случаях — стрептомицином.

**Интоксикация хроническая туберкулезная, или туберкулез без ясной локализации.** Чаще всего наблюдается у детей дошкольного и среднего школьного возраста. Интоксикация может распространяться из любых лимфатических узлов, пораженных туберкулезом, но чаще из бронхиальных узлов. Часто распознать туберкулез бронхиальных желез трудно.

**Симптомы и течение.** Отсталость в физическом развитии, плохой аппетит, небольшие периодические повышения температуры, большая утомляемость, головные боли, плохой аппетит, бледность. Много плотных увеличенных шейных лимфатических узлов. Течение при раннем распознавании благоприятное.

**Лечение.** Освобождение от занятий (полное или частичное), санаторное лечение или проведение санаторного режима дома.

**ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ (TUBERCULOSIS PULMONUM).** Наиболее частая форма — инфильтрат, развивающийся вокруг туберкулезного очага чаще всего вокруг места внедрения туберкулезной палочки (первичного очага) — первичный инфильтрат, или первичная пневмония.

**Симптомы и течение.** Начало обычно острое, вначале высокая температура, кашель, плохой аппетит и сон, раздражительность, вялость. При перкуссии — притупление. Острый период тянется 2—3 недели. Температура снижается, но еще долго может давать небольшие повышения. Общее состояние быстро улучшается: инфильтрат медленно рассасывается. При неблагоприятном течении образуются каверны (чаще у детей раннего возраста и подростков). При неблагоприятном течении легочного инфильтрата и брон

»

аденита нередко также развивается милиарный туберкулез легких и туберкулезный менингит.

**Лечение.** В остром периоде — постельный режим, полноценное питание, обилие витаминов, свежий воздух, лечение стрептомицином в комбинации с ПАСК. При образовании каверн — искусственный пневмоторакс и алкоголизация диафрагмального нерва.

В период затихания процесса — гигиено-диететический, санаторный режим: 1) свежий воздух и солнце; 2) рациональное питание; 3) чередование покоя с дозированной физической нагрузкой. При образовании каверн — иногда искусственный пневмоторакс и алкоголизация диафрагмального нерва.

Для повышения тонуса и закаливания детского организма полезно проводить водные процедуры в виде ежедневного душа по утрам: слабым и лихорадочным больным — обтирание теплой водой.

Пища должна содержать (по общему количеству калорий) 15% белков, 20—35% жиров, а также углеводы, витамины и соли; поэтому в пищевой рацион больного должно входить сливочное и топленое масло, яйца, мясо, сырые и вареные овощи, ягоды и фрукты. Рыбий жир необходимо давать во всех возрастах 1—2 раза в день по десертной или столовой ложке. Милиарный туберкулез и туберкулезный менингит лечатся с успехом стрептомицином, лучше в комбинации с ПАСК. Чем раньше начато лечение, тем лучше результаты.

**ХРОНИЧЕСКИЕ РАСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И ПИЩЕВАРЕНИЯ** см. *Гипотрофия*.

**ЭМПИЕМА** см. *Плеврит гнойный*.

**ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ.** В течение первого года необходимо грудное вскармливание. Первый раз ребенка прикладывают к груди через 12 часов после рождения, в зависимости от состояния ребенка и матери. В дальнейшем нужно кормить регулярно каждые 3 часа с ночным перерывом в 6 часов, так как желудок ребенка опорожняется только через 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3 часа после кормления, а деятельность пищеварительных желез особенно активна в привычные для ребенка часы кормления. До 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> недель — 7 раз, т. е. через 3 часа; от 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> недель до 2 месяцев кормят через 3—3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа, т. е. 6—7 раз в сутки, после 2 месяцев — через 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа, т. е. 6 раз, и с 4 месяцев — через 4 часа, т. е. 5 раз в сутки.

Перед каждым кормлением нужно обмыть соски и околососковый кружок кипяченой водой, после кормления обтереть сухой ваткой или марлей. Необходимо раз в сутки (утром перед первым кормлением) обмывать груди теплой водой с мылом.

При сосании ребенок должен захватывать не только сосок, но и околососковый кружок; при этом нужно следить, чтобы из-за сильного прижатия носа к груди матери носовое дыхание у ребенка не было затруднено.

Поза матери, положение ребенка у груди должны быть всегда одинаковыми и удобными для ребенка для того, чтобы у него выработался положительный условный рефлекс на обстановку, па грудь матери. Во время кормления грудью в комнате не должно быть громких разговоров. Нельзя допускать, чтобы ребенок сильно

беспокоился перед кормлением; перевозбужденный и утомленный он хуже ест.

Длительность кормления ребенка грудью не должна превышать 20—25 минут. Обычно ребенок насыщается в течение 10—15 минут. При каждом кормлении надо прикладывать ребенка попеременно только к одной груди и полностью опорожнять ее. Прикладывать ребенка и к одной, и к другой груди за один раз можно лишь при недостаточном количестве молока у матери.

При избытке молока у матери, в особенности в первый месяц жизни ребенка, нужно сцеживать избыток молока после кормления.

Количество молока, получаемого ребенком за один раз, определяется взвешиванием его до и после кормления. Необходимое ребенку количество молока колеблется в зависимости от возраста: в возрасте от 2 недель до 2 месяцев ребенок в сутки должен получать молоко в количестве, равном  $V_5$  его веса, от 2 до 4 месяцев —  $V_5$ , от 4 до 6 месяцев —  $V_7$ , от 6 месяцев до 1 года —  $V_8$  веса (но не больше 1 л).

С 5—6 месяцев здорового, нормально развивающегося ребенка надо постепенно прикармливать.

Основные виды продуктов для прикорма по возрастам:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 5% манная каша на половинном молоке | 5—6 месяцев |
| 5% » » » цельном                    | 6—7 »       |
| 10% » » » »                         | 6—7 »       |
| Картофельное пюре                   | 6—7 »       |
| Овощное пюре                        | 7—8 »       |
| Фруктовый кисель                    | 7—8 »       |
| Мясной бульон                       | 9—10 »      |
| » фарш                              | 10—11 »     |
| Яичный желток                       | 6—9 »       |
| Творог                              | 6—9 »       |
| Сухарь или печенье                  | 7—8 »       |
| Свежее фруктовое пюре               | 6—7 »       |
| Цельное молоко                      | 10—12 »     |

С постепенным увеличением прикорма уменьшается число кормлений грудью.

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| В 5—6 месяцев | 4 раза грудь и 1 раз прикорм          |
| » 7 »         | 3 » » » 2 раза »                      |
| » 9 »         | 2 » » » 2 » » и 1 раз грудь и прикорм |
| » 11 »        | 1 раз » » 3 » » » 1 » » » »           |

Здорового ребенка нужно к году отнять от груди, но не летом, в жаркое время года.

С 2—3-месячного возраста ребенку начинают давать овощные, ягодные или фруктовые соки — по 1—2 чайных ложки в день, постепенно прибавляя, дойти к году до 100 г сока в день. С 3 месяцев нужно также давать рыбий жир, начав с половины чайной ложки в день и, постепенно увеличивая, довести его количество к 5—6 месяцам до 2 чайных ложек в сутки.

Затруднения грудного вскармливания со стороны матери

1. Тугая грудь, ребенку трудно захватывать сосок. Перед кормлением нужно немного сцедить молоко — грудь смягчится, и ребенок без труда сможет сосать.

2. Трещины сосков — мастит. Смазывание трещин рыбьим жиром, мази на рыбьем жире, облучение ртутно-кварцевой лампой. Достаточно опорожнять грудь, кормить ребенка через наладку.

При мастите, сопровождающемся высокой температурой, наличии гноя в молоке прекратить кормление; после падения температуры, при рассасывании инфильтрата или же после разреза гнойника вновь приложить ребенка к груди.

3. Гипогалактия (недостаточная секреция молока из груди). Соблюдение правил кормления ребенка грудью, достаточное и полноценное питание матери, нормальный образ ее жизни. Если эти мероприятия не дают должных результатов, продолжать кормление грудью, но ввести ранний прикорм.

4. Менструация и новая беременность. При менструации продолжать кормление грудью. При новой беременности продолжать кормление грудью, но рано начать прикорм; отнимать ребенка от груди в начале второй половины беременности.

5. Заболевания матери (активный туберкулез, декомпенсированный порок сердца, тяжелая форма нефрита, диабет в тяжелой форме, тяжелая форма базедовой болезни, эпилепсия, психические болезни и др.); при этих заболеваниях не разрешается кормить ребенка грудью.

6. При острых инфекционных заболеваниях (чума, скарлатина, ветряная оспа, грипп, ангина, воспаление легких) можно продолжать грудное вскармливание при строгом соблюдении всех гигиенических условий и если общее состояние матери не внушает серьезных опасений.

Затруднения грудного вскармливания со стороны ребенка

1. Плохой сон ребенка — сильное возбуждение его. Необходимо создать для каждого возраста правильный режим сна и бодрствования.

2. Вялое состояние ребенка (слабые, недоношенные дети). В каждое кормление прикладывать ребенка ненадолго к груди и докармливать сцеженным грудным молоком.

Смешанное вскармливание. Если на грудном вскармливании ребенок плохо развивается, недостаточно или совсем не прибавляет в весе, приходится его рано докармливать. Прежде чем перейти к смешанному вскармливанию, нужно установить количество высасываемого ребенком молока из груди матери путем повторных взвешиваний ребенка до и после кормления. Докармливать нужно постепенно, соответственно весу, возрасту и состоянию ребенка. До-корм можно давать либо как добавочное питание к каждому грудному кормлению, либо как самостоятельное кормление, чередуя с прикладыванием к груди. К последнему приходится прибегать, если мать не в состоянии в каждое кормление ребенка даже из обеих грудей дать ему хотя бы 10% требуемой порции.

Общее количество кормлений, время отлучения от груди, последовательность введения различных сортов блюд та же, как при естественном вскармливании.

Схема искусственного вскармливания

| № | Вес в г | Суточное количество в г |       |           |          | Название пищи                                    | Количество кормлений и дозировка в г | Суточное количество различных видов пищи                                                                                                                             |
|---|---------|-------------------------|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | белки                   | жиры  | угле-воды | кэло-рии |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                      |
| 1 | 18,48   |                         | 54,   |           | 449      | В-рис + 5% сахара То же                          | 7X100,0                              | 700,0 В-рио                                                                                                                                                          |
| 2 | 20,6    |                         | 65,   |           | 541      | То же В-рис + 5 % сахара +                       | 7X120,0                              | 840,0 В-рис+2 чайные ложки фруктового сока                                                                                                                           |
| 3 | 20,6    |                         | 73,   |           | 628      | 1% муки То же +5% манная                         | 6X150,0                              | 900,0 В-рис+ 30,0фруктового сока + одна чайная ложка рыбьего жира                                                                                                    |
| 4 | 23,5    |                         | 95,8  |           | 776      | каша                                             | 6X150,0                              | 900,0 В-рис+ 30,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира                                                                                                      |
| 5 | 26,4    |                         | 110,0 |           | 830      | То же, овощное пюре, фрукт- 5X180,0 товый кисель | 5X180,0                              | 720,0 В-рис+180,0 5% манной каши + 50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира                                                                                |
| 6 | 30,87   |                         |       |           |          |                                                  |                                      | 720, 0 В-рис+180,0 10% манной каши + 50,0 фруктового сока+2 чайные ложки рыбьего жира                                                                                |
| 7 | 31,0    |                         |       |           |          |                                                  |                                      | 540,0 В-рис + 180,0 10% манной каши + 100,0 картофельного пюре+100,0 фруктового киселя + 50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
| 8 | 24,94   | 30,9                    |       |           |          |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                      |
| 9 | 2*,12   |                         |       |           |          |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                      |



Продолжение

| №  | Вес в г | Суточное количество в г |      |           |          | Название пищи                                                                                                | Количество кормлений и дозировка в г | Суточное количество различных видов пищи                                                                                                                                                             |
|----|---------|-------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | белки                   | жиры | угле-воды | кало-рии |                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | 8 280   | 26,9                    | 35,0 | 120,0     | 927      | Цельное молоко + 5 % сахара, 10% манная каша, овощное пюре, фруктовый кисель, картофельное пюре, овощной суп | 5X200,0                              | 400,0 цельного молока + 200,0 10% манной каши + 100,0 овощного пюре + 200,0 фруктового киселя + 100,0 картофельного пюре+50,0 фруктового сока + 2 чайные ложки рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь |
| 9  | 8 550   | 26,9                    | 38,0 | 120,0     | 954      | То же + 3% масла с пюре                                                                                      | 5X200,0                              | То же                                                                                                                                                                                                |
| 10 | 8 925   | 26,9                    | 38,0 | 120,0     | 954      | То же                                                                                                        | 5x200,0                              | То же + 15,0 мясного пюре                                                                                                                                                                            |
| 11 | 9 140   | 29,3                    | 38,2 | 118, 3    | 964      | Цельное молоко+ 5% сахара, 10% манная каша                                                                   | 5X200,0                              | 400,0 цельного молока + 200,0 10% манной каши + 50,0 мясного бульона + 100,0 овощ-                                                                                                                   |
| 12 | 9 480   | 31,4                    | 38,0 | 114       | 973      | Мясной бульон, мясное пюре, овощное пюре, картофельное пюре, фруктовый кисель                                |                                      | мясного пюре + 20,0 мясного пюре + 200,0 фруктового киселя+100,0 картофельного пюре + 50,0 фруктового сока + 2 чайные лож-и рыбьего жира + тертое яблоко + сухарь                                    |

Выбор молочных смесей для добавочного кормления зависит от возраста и состояния ребенка к моменту перевода его на смешанное вскармливание.

Здорового ребенка после 2 месяцев жизни можно докармливать коровьим молоком, разведенным вначале пополам с рисовым или овсяным отваром с добавлением к нему 5% сахара, переходя на разведение с  $\frac{1}{2}$  отвара; ребенка самого раннего возраста и ослабленного нужно докармливать кислыми смесями (подкисленная смесь В-рис, В-кефир). При сметанном вскармливании пища ребенка должна содержать на 5—10% калорий больше, чем при естественном кормлении.

Ребенку до 2 месяцев нужно давать докорм из ложечки или из соски с маленьким отверстием, чтобы ребенок производил сосательные движения, в противном случае он постепенно откажется от материнской груди.

Искусственное вскармливание. При отсутствии молока у матери, а также при безусловных противопоказаниях у матери или ребенка к кормлению грудью приходится вскармливать его только молочными смесями (искусственно), причем количество кормлений за сутки и количество пищи, принимаемой за один раз, остаются такими же, как при естественном и смешанном вскармливании.

При искусственном вскармливании здоровому ребенку дают в первые недели жизни коровье молоко пополам с водой (смесь № 2), в дальнейшем с  $\frac{2}{3}$  воды или отвара (№ 3— смесь В). К этим смесям добавляются сливки или коровье молоко из расчета 1% жира. Прикорм в виде густых блюд (каши, пюре и др.) можно дать раньше на 1/2 месяца при грудном кормлении. При плохом развитии ребенка, в случаях рахита назначается аскорбиновая кислота  $0,05\text{—}0,1\text{ г}$  в сутки витамин D (см. *Лечение рахита*), начиная с 1/2—2 месяцев. Калорийность пищи должна быть приблизительно на 10% выше, чем при естественном вскармливании. Питание детей в возрасте от 1 года до 4 лет. После 1 года дети должны получать 90—100 калорий на 1 кг веса; 3—3,5 г белка, 4—4 г жира и 15—17 г углеводов на 1 кг веса; ребенка в возрасте до 1/2 лет кормят 5 раз в день, в возрасте старше 1/2 лет — 4 раза.

По количеству калорий, полагающихся ребенку за сутки, первый завтрак должен равняться 25%, обед — 35—40%, полдник — 10—15% и ужин — 25% суточного рациона. Пища до 1/2 лет — протертая, а свыше 1/2 лет должна быть разнообразной.

С 1/2 лет ребенка нужно приучать есть самостоятельно, начиная обучение с густой пищи, мыть руки перед едой, правильно держать ложку, уметь пользоваться салфеткой. К 2 годам ребенок должен не только опрятно и самостоятельно есть, но спокойно сидеть за столом, ожидая следующего блюда. Ребенок нередко отказывается от нового вида пищи. Надо терпеливо и настойчиво давать полагающуюся ему пищу, насильно не принуждать, не применять угроз, чтобы не выработать отрицательного отношения к приему пищи, так как только на пищу, которая съедается с аппетитом, выделяется достаточное количество соков пищеварительных желез.

## \* ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ

## Физиологические нормы питания в СССР

Физиологические нормы питания населения Советского Союза, предлагаемые Институтом питания Академии медицинских наук СССР, получили одобрение Президиума Академии медицинских наук СССР, Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения СССР и утверждены Министерством здравоохранения СССР (см. табл. 1, 2, 3, 4 и 5).

Накопившийся огромный материал позволил подойти к составлению оптимальных физиологических норм питания с учетом вида труда (профессии), возраста и других социально-бытовых и биологических особенностей внешней среды, оказывающих воздействие на организм человека. Кроме того, специально разработан ассортимент продуктов, обеспечивающий потребность людей не только в основных пищевых веществах (белки, жиры, углеводы), но и в минеральных веществах и витаминах.

Уверенно можно сказать, что ни в одной стране не могут быть разработаны и проведены в жизнь такие нормы питания, как в Советском Союзе, где вопросам питания населения уделяется огромное внимание со стороны партии, правительства и лично великого Сталина.

Т а б л и ц а 1

## Распределение профессий по группам калорийности

| Группа I, калорийность 3 000-3 200       | Группа II, калорийность 3 500                  | Группа III, калорийность 4 000                   | Группа IV, калорийность 4 500—5 000                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Профессии, связанные с физическим трудом | Профессии, связанные с механизированным трудом | Профессии, связанные с немеханизированным трудом | Профессии, связанные с тяжелым немеханизированным трудом |

Т

а б л и ц а 2 Физиологические нормы потребности в белках, жирах, углеводах и калориях для взрослых (в сутки в граммах)

|                                                 | Группы |         |         | В среднем<br>на<br>человека |
|-------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------|
|                                                 | I      | II      | III     |                             |
| Белки .....                                     | 109 67 | 122 72  | 141 82  | 163 94                      |
| в том числе животные .....                      | 106 91 | 116 95  | 134 108 | 153 121                     |
| Жиры .....                                      | 433 3  | 491 355 | 558 4   | 631 4                       |
| в том числе животные .....                      | 208    | 592     | 112     | 678                         |
| Углеводы .....                                  |        |         |         | 415                         |
| Калории в единицах .....                        | 1 211  | 1 287   | 1 449   | 1 641                       |
| в том числе за счет животных<br>продуктов ..... |        |         |         | 3 053                       |
|                                                 |        |         |         | 1 144                       |

Т а б л и ц а  
3

|       |      |    |    |
|-------|------|----|----|
| ft    | о    | о  | о  |
| ago   | И    | ни | о  |
| Н к " | со п |    |    |
| о ЕС  | ни.  | о- | 52 |
|       |      |    | и  |

S2

|                            |     |       |       |      |     |     |     |    |    |       |
|----------------------------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-------|
|                            | 25  | 48    |       | 78   | 50  | 81  | 98  | 56 | 86 | 119   |
| Велкп .....                | 21  | 39    | 48    | 72   | 297 | 75  | 424 | 2  |    | 72    |
| в том числе ншпотные ..... | 25  | 51    | 65    | 1291 |     | 940 |     |    |    | 99    |
| Жиры.....                  | 25  | 50    | 61    |      |     |     |     |    |    | 84    |
| в тем числе животные . . . | 25  | 50    | 241   | 966  | 1   | 031 |     |    |    | 471   |
| Углеводы . .«.....         | 109 | 157   | 1 871 |      |     |     |     |    |    | 3 340 |
| Калории в единицах.....    | 732 | 1 315 |       |      |     |     |     |    |    |       |
| в том числе животных про   |     |       |       |      |     |     |     |    |    |       |
| дуктов .....               | 396 | 727   | 855   |      |     |     |     |    |    | 1 181 |
| 1                          |     |       |       |      |     |     |     |    |    |       |

Т а б л и ц а 4

Физиологические нормы потребности в основных минеральных веществах  
(в сутки в миллиграммах)

Возрастные группы

|                                        |         |           |        |
|----------------------------------------|---------|-----------|--------|
|                                        | Кальций | Фосфор    | Железо |
| Дети от 1 года до 11 лет .....         | 1 000   | 1 500     | 15 15  |
| Дети и подростки от 11 до 18 лет ..... | 1 000   | 1500-2000 | 15     |
| Взрослые.....                          | 800     | 1 600     |        |

Т  
а в процентах

Удельный вес различных овощей в питании, выраженный в  
общему количеству

б л и ц а 5

Ассортимент овощей

|                                                  |       |     |
|--------------------------------------------------|-------|-----|
| 1. Капуста белокочанная                          | 21,5  |     |
| 2. • цветная . . .                               | 3,8   | 0,9 |
| 3. » красная . . .                               | 2,7   |     |
| 4. » брюссельская, савойская и ДР-               | 18,3  |     |
| 5. Томаты .....                                  | 16,7  |     |
| 6. Морковь .....                                 | 4,6   | 0,9 |
| 7. Свекла .....                                  | 1,8   | 0,9 |
| 8. Репа.....                                     | 7,5   |     |
| 9. Брюква.....                                   |       |     |
| 10. Редис и редька . . . Огурцы .... Баклажаны а |       |     |
| 11. Лук .....                                    |       |     |
| 12. абачкп Зеленый горошек .....                 | 6,2   | 1,4 |
| 13. Бобовые овощи .....                          | 1,8   | 2,7 |
| 14. Салат .....                                  | 0,9   | 0,5 |
| 15. Шпинат .....                                 | 1,8   |     |
| 16. Шавель .....                                 | 1,2   |     |
| 17. Укроп, петрушка, пастернак, сельдерей        | 2,7   |     |
| 18. Хрен.....                                    |       |     |
| 19. Прочие овощи .....                           |       |     |
| 20. Итого                                        |       |     |
| 21.                                              | 100,0 |     |

Т а б л и ц а 6

Минимальная суточная потребность человека в витаминах  
(в миллиграммах)

Утверждено Ученым медицинском советом Министерства  
здравоохранения СССР

| Категория         | Витамины |       |                |       |        |       |                |
|-------------------|----------|-------|----------------|-------|--------|-------|----------------|
|                   | А        |       |                | а     | а      | Л     | S a            |
|                   | т Я га   | и а » | и о с р. а к а | ра (Я | а * га | и М О | * Ни Рн        |
| 1. Взрослый чело- |          |       |                |       |        |       |                |
| век:              |          |       |                |       |        |       |                |
| а) при средней    | 3300     | 1     | 2              | 2     | 2      | 50    | IУ             |
| затрате труда .   |          |       |                |       |        |       |                |
| б) при тяжелом    | 3 300    | 1     | 2              | 2,5   | 2      | 75    | 20 > До 1000   |
| труде . . . .     |          |       |                |       |        |       |                |
| в) при очень тя-  | 3 300    | 1     | 2              |       | 2      | 100   | 25J            |
| желом труде .     |          |       |                |       |        |       |                |
| 2. Беременные     |          |       |                |       |        |       |                |
| (5—8 меся ев) .   | 6 600    | 2     | 4              | 2,5   | 2      | 75    | 20 500- -1000  |
| 3. Кормящие (до 7 |          |       |                |       |        |       |                |
| месяцев) . . . .  | 8 300    | 2,5   | 5              | 3     | 2      | 100   | 25 500- -1000  |
| 4. Дети:          |          |       |                |       |        |       |                |
| а) до 7 лет . . . | 3 300    | 1     | 2              | 1     | 2      | 30—   | 15 500- -1000  |
| б) от 7 до 14 лет | 3 300    | 1     | 2              | 1,5   | 2      | 50    | 15 500- -1 000 |
| в) свыше 14 лет   | 3 300    | 1     | 2              | 2     | 2      | 50    | 15 500- -1000  |

П о я с н е н и е к т а б л и ц е . Потребность человека в витамине А  
выражена в таблице тремя способами: 1) в интерна: но-пальных единицах (ИЕ),  
2) в миллиграммах витамина А и 3) в миллиграммах каротина.

1 мг витамина А соответствует 3 330 ИЕ, а 1 мг каротина ((3-ка-ротина) —1  
660 ИЕ.

1 ИЕ витамина D соответствует 0,000025 мг химически чистого витамина D  
(кальциферола).

\* Рибофлавин.

\*\* Никотиновая кислота.

1 ИЕ для А-витаминной активности соответствует активности 0,0006 мг каротина ( $\beta$ -каротина) или 0,0003 мг витамина А.

Основной уровень витамина А может быть доставлен потребителю в виде пищевых средств. Дополнительное снабжение витамином А должно быть осуществлено путем дачи витаминных препаратов (каротина, или витамина А).

Применение витаминов D и PP должно производиться по назначению врача.

В соответствии с установленной Ученым медицинским советом Министерства здравоохранения СССР суточной дозой препарата витамина D (кальциферола) в профилактических целях рекомендуется доза в 1 000 ИЕ.

1 мг витамина B<sub>1</sub> соответствует 330 ИЕ (содержание витаминов в полвуктах см. ниже).

Т а б л и ц а 7

Примерные нормы продуктов для детей в яслях за один день  
(в граммах)

| Наименование продуктов                                | От 1 года<br>до 1 года<br>6 месяцев | От 1 года 6 меся-<br>цев до 3—4 лет |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Хлеб.....                                             | 150                                 | 200                                 |
| Молоко.....                                           | 500                                 | 500                                 |
| Мясо или рыба .....                                   | 50                                  | 60                                  |
| Масло сливочное .... - •                              | 25                                  | 25                                  |
| „ растительное .....                                  | 40                                  | 40                                  |
| Крупа.....                                            |                                     | 20                                  |
| Лапша или вермишель.....                              | 30                                  | 50                                  |
| Мука пшеничная.....                                   | 10                                  | 10                                  |
| Мука картофельная .....                               | 30                                  | 50                                  |
| Сахар .....                                           | 15                                  | 30                                  |
| Яйца.....                                             | 15                                  | 30                                  |
| Сметана.....                                          | 15                                  | 30                                  |
| Творог .....                                          | 15                                  | 30                                  |
| Овощи (картофель, морковь, капуста<br>лук и др.)..... | 350                                 | 450                                 |
| Ягоды (клюква, брусника и т. п.)                      | 15                                  | 15                                  |

# ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЛОРИЙНОСТЬ НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

X

»

Д

[illegible]

ВОПРОСЫ  
IV. Яйцо куриное 2 шт. (100 г)  
V. Хлеб, крупы. Макаровы  
и другие богатые углеводами

## Продолжение

В 100 г продукта (нетто)  
содержится усвояемых  
веществ в граммах

| № п/п | Наименование продуктов              | белков | угле-<br>водов | число<br>калорий |
|-------|-------------------------------------|--------|----------------|------------------|
|       | продукты                            | 12,2   | 11,5           | 0,5              |
|       | Варенье .....                       |        |                |                  |
|       | Крупа манная .....                  |        |                |                  |
|       | » гречневая .....                   |        |                |                  |
|       | » овсяная .....                     |        |                |                  |
|       | » пшено .....                       | 8,0    | 66,7           | 73,6             |
|       | » рисовая .....                     | 8,0    | 64,4           | 61,1             |
|       | » ячневая и перловая .....          | 9,1    | 62,4           | 71,7             |
|       | Мука картофельная .....             | 7,4    | 67,3           | 72,7             |
|       | » пшеничная .....                   | 6,5    | 68,6           | 73,3             |
|       | Макароны, лапша .....               | 10,7   | 75,9           | 73,5             |
|       | Мед .....                           | 0,6    | 51,2           | 94,5             |
|       | Печенье разное .....                | 0,7    | 58,1           | 45,2             |
|       | Сироп ягодный (варенье) .....       | 0,9    | 56,0           | 39,3             |
|       | Сахар (песок) .....                 | 9,2    |                |                  |
|       | Сухари пшеничные .....              | 1,0    |                |                  |
|       | Хлеб пшеничный грубый, лучший ..... | 6,7    | 6,7            |                  |
|       | » ржаной .....                      | 8,1    | 1,2            |                  |
|       |                                     | 6,9    | 0,4            | 0,5              |
|       |                                     | 5,5    | 0,6            |                  |

## VI. Овощи

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| Горох .....          | 3,2 | 50,0 |
| Кабачки свежие ..... |     | 4    |
| Капуста .....        | 0,1 | 2    |
| » квашеная .....     | 0,3 | 18   |
| Картофель .....      | 0,2 | 7    |
| » репчатый .....     | 0,1 |      |
| Гуляк .....          |     | 3    |
| Помидоры .....       |     | 3    |
| Редиска .....        | 0,1 | 0,2  |
| Ген .....            |     | 3    |
| Са.пат. .....        |     |      |
| Свекла .....         |     |      |
| Фасоль .....         | 0,4 | 9    |
| Шпинат .....         |     | 50,0 |
| Щавель .....         |     | 3,0  |
|                      |     | 2,8  |

## VII. Фрукты и ягоды

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| Абрикосы свежие .....      |     |     |
| » сушеные (курага) .....   |     |     |
| Апельсины .....            | 1,1 |     |
| Ароузы .....               |     |     |
| Винные ягоды сушеные ..... | 0,5 | 0,4 |
| Виноград .....             |     |     |
| » сушеный (изюм) .....     | 0,1 | 0,9 |
| Вишни свежие .....         |     |     |
| Грунта .....               |     |     |
| Дыня .....                 |     |     |
| » Клюква .....             |     |     |
| » Компот сухой .....       |     |     |
| Мандарины .....            |     |     |
| Сливы свежие .....         |     |     |
| Яблоки .....               |     |     |

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ<sup>1</sup>  
(витамины в мг на 100 г продукта)<sup>2</sup>

| Наименование продукта                | Количество витаминов |           |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                      | В.                   | В. PP     |
| 1. Мясные и рыбные продукты          |                      |           |
| Ветчина .....                        | 0,04                 | 0,25      |
| Мясо разное и птица .....            | 0,01                 | 0,25      |
| » разных рыб .....                   | 0                    |           |
| » соленых и копченых рыб .....       | 30                   | 20,9,2    |
| Печень крупного рогатого скота ..... |                      | 30        |
| Почки .....                          |                      | 0,25      |
| Свинина .....                        |                      | 1,5       |
| Сердце быка .....                    |                      | 0,2       |
| Сельдь жирная .....                  | 3,6-4,2              | 0,5       |
| » нежирная .....                     | 0,03                 | 0,1—0,1—0 |
| 2. Молочные продукты и яйца          |                      |           |
| Молоко коровье .....                 | 0,1                  | 0,2       |
| Кумыс .....                          |                      | 0,07      |
| Сливки и сметана .....               | 0,8                  | 0,15      |
| Сыр жирный .....                     | 0,03                 | 0,9       |
| Творог .....                         |                      | 20        |
| Яйца (на 1 шт.) .....                | 1,3                  | 0,07      |
| 3. Масла и жиры                      |                      |           |
| Масло сливочное и топленое .....     | 1,2                  | 1,4       |
| » растительное .....                 | 0,80                 |           |
| » пальмовое .....                    | 80                   |           |
| » из облепихи .....                  | 0                    |           |
| Маргарин .....                       |                      |           |
| Сало говяжье .....                   | 0,38                 |           |
| » свиное .....                       |                      |           |
| Рыбий (тресковый) жир .....          |                      | 125-750   |
| 4. Зерновые и изделия из них         |                      |           |
| Крупа гречневая .....                |                      |           |
| » манная .....                       |                      |           |
| » овсяная .....                      |                      | 0,16      |
| » перловая .....                     |                      | 1,1       |
| » пшеничная .....                    |                      |           |
| » ячневая .....                      |                      | 0,08      |
| » рисовая .....                      |                      |           |

<sup>1</sup> Составлено по руководству «Нормы суточного потребления витаминов и таблицы содержания витаминов в пищевых продуктах», Медгиз, 1946.  
Содержание витаминов В., РР и D, а также содержание витаминов в тех продуктах, которых нет в указанном выше руководстве, взято из следующих пособий:  
Б у к и н В. Н., Витамины, Пищепромиздат, 1940.  
П е в з н е р Л. М., Основы технологии приготовления пищи для больного, Медгиз, 1946.  
Е ф р е м о в в. В., Авитаминозы, Медгиз, 1944.  
<sup>2</sup> Витамин D, ввиду малых величин, дается в гаммах(Г) на 100 г продукта.



## Продолжение

| Наименование продукта              | Количество витаминов |       |          |         |
|------------------------------------|----------------------|-------|----------|---------|
|                                    | 0,15                 | 0,08  | 1,5      |         |
| Кукуруза — цельное зерно           | 0                    |       |          |         |
| » белая                            | 0,3                  |       |          |         |
| » желтая                           | 0                    |       |          |         |
| Лапша                              | 0                    | Следы |          |         |
| Макароны                           | 0                    |       |          |         |
| Мука пшеничная (82—94 %) »         | 0                    | 0,3   | 0,1      |         |
| ржаная целого помола               | 0                    | 0,2   | 0,06     |         |
| Овес — зерно                       | 0                    | 0,4   | 0,06     |         |
| Отруси пшеничные                   | Следы                | 0,88  | 1,1 5,9  |         |
| Пшеница — цельное зерно »          | 0                    | 0,4 2 | 0,12     |         |
| зародышевая часть                  | 0,6                  |       | 0,7      |         |
| Соя                                | 0,5                  |       | 0,16     |         |
| » желтая                           | Следы                | 0,3   | 1        | —       |
| Хлеб из целой пшеницы . . . » муки | 0                    | 0,03  | 0,1      | —       |
| тонкого помола » » ржаной          | 0                    | 0,15  | 0,05     | —       |
| муки                               |                      |       |          | 7       |
| 6. Овощи свежие                    |                      |       |          |         |
| Арбуз                              | 0 0                  | 0,03  |          |         |
| Баклажаны                          | Следы                |       | —        | 15      |
| Брюква                             | 0,5                  |       | —        | 30      |
| Бобы зеленые .... Горошек зеленый  | 1                    | 0,3   | 0,19     | 0,75 25 |
| Дыня                               | 0                    |       | —        | 20      |
| Кабачок                            | Следы                |       | —        | 15      |
| Капуста белокочанная               | 3                    | 0,06  | 0,05     | 0,29 30 |
| » зеленая                          | Следы                | 0,22  | 0,05     | — 30    |
| » цветная                          | 0,5                  |       | —        | 70      |
| » краснокочанная                   | Следы                |       | —        | 50      |
| » брюссельская                     | 0                    |       | —        | 50      |
| Картофель                          | 0                    | 0,06  | 1,16     | 10 40   |
| Кольраби                           | 0                    |       | —        | 60 20   |
| Лук зеленый (перо)                 | 0                    |       | —        | 10 5    |
| » порей                            | 0                    |       | 0,02 0,1 |         |
| » репчатый                         | 0                    |       | 1,5      |         |
| Морковь красная                    | 0                    |       |          |         |
| » желтая                           | Следы                | 0,09  | 0,15     |         |
| Огурцы                             | Следы                |       |          |         |
| Перец красный (сладкий, горький)   | 10                   |       |          | 250     |
| Петрушка (лист)                    | 10                   |       |          | 150 20  |
| Редис                              | Следы                | 0,1   |          | 25 20   |
| Редька                             | »                    |       |          | 30 10   |
| Репка                              | 0,1                  | 0,04  | 0,06     | 10 25   |
| Салат темнозеленый . . . »         | 2,5                  | 0,08  | 0,17     | 40      |
| оветлозеленый ...                  | Следы                |       |          |         |
| Свекла красная                     | 0                    | 0,14  |          |         |
| Спаржа                             | 1,25                 |       |          |         |
| Томат красный                      | 2 0,5                | 0,05  | 0,05     | 0,58    |
| » желтый                           | 0,2                  |       |          |         |
| Тыква                              |                      |       |          | 150     |
| Укроп                              |                      |       |          | 200     |
| Хрен (корень)                      |                      |       |          | Следы   |
| Чеснок                             |                      |       |          | 40      |
| Чемерица                           |                      | 0,07  | 0,25     | 0,72 50 |
| Шпинат                             |                      |       |          | i       |

## Продолжение

| Наименование продукта                                    | В,    |          |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|
| 6. Ботва огородная                                       |       |          |
| Брюква                                                   |       | 0,5      |
| Морковь                                                  |       | 8        |
| Петрушка                                                 | 10 4  | 0,1      |
| Редис                                                    | 4 3   |          |
| Редька                                                   | 6,6   |          |
| Репка                                                    | 0,3   |          |
| Свекла                                                   |       |          |
| 7. Овощи и ботва квашеные и соленые                      |       |          |
| Капуста квашеная в дощниках и заполненных доверху бочках |       | 0,1      |
| Капуста квашеная рыночная                                |       |          |
| лежалая                                                  | 0     |          |
| Огурцы соленые                                           | 0     |          |
| Помидоры соленые зеленые                                 | Следы | 0,1      |
| 8. Плоды (фрукты, ягоды и пр.)                           |       |          |
| Абрикосы свежие . »                                      |       | 0,02     |
| сушеные . Апельсины ....                                 |       |          |
| Барбарис                                                 |       | 0,07     |
| Брусника                                                 |       |          |
| Виноград                                                 |       |          |
| Вишня                                                    |       |          |
| Голубика                                                 |       |          |
| Гранат                                                   |       |          |
| Грейпфрут . . .                                          |       |          |
| Груша                                                    |       |          |
| Ежевика                                                  |       | 0,05     |
| Земляника лесная                                         |       | 0,11     |
| Изюм                                                     |       |          |
| Кизил                                                    |       |          |
| Клюква свежая                                            |       |          |
| » лежалая                                                |       |          |
| Клубника                                                 |       |          |
| Крыжовник                                                |       |          |
| Лимоны                                                   |       |          |
| Малина                                                   |       |          |
| Мандарины                                                |       |          |
| » корки                                                  |       |          |
| Маслнм                                                   |       | 0/08     |
| Морошка                                                  |       |          |
| Облепиха (рыночная мороженая)                            |       |          |
| Орехи грецкие зеленые . . . »                            |       |          |
| земляные (арахис) . . .                                  |       |          |
| Персики                                                  |       | 0,8 0,03 |
| Рябину (рыночная)                                        |       |          |
| Сливы                                                    |       |          |

Количество витаминов  
В, рр

|      | 4    | 5 | 6     | 7 |
|------|------|---|-------|---|
|      |      |   | 120   |   |
| —    | —    |   | 80    |   |
| —    | —    |   | 150   |   |
| —    |      |   | 100   |   |
| —    |      |   | 1150  |   |
|      | —    |   | 130   |   |
|      |      |   | 20-50 |   |
|      |      |   | 20    |   |
|      |      |   | Следы |   |
| -    | -    |   | 0     |   |
| 0,1  |      |   | 7     |   |
| 0,03 | 0,22 |   | 40    |   |
| —    | —    |   | 150,1 |   |
| —    | —    |   | 15    |   |
|      | "    |   | 3     |   |
| —    | —    |   | 15    |   |
|      |      |   | 20    |   |
|      |      |   | 5     |   |
| 0,GS | —    |   | 40    |   |
|      |      |   | 1     |   |
|      |      |   | 5     |   |
|      |      |   | 30    |   |
| —    | —    |   | 0     |   |
| —    | —    |   | 50    |   |
| —    | —    |   | 10    |   |
|      |      |   | 0^    |   |
|      | ^    |   | 68    |   |
|      |      |   | 50    |   |
|      |      |   | 40    |   |
| —    | —    |   | 30    |   |
|      | —    |   | 30    |   |
| —    | —    |   | 1иО   |   |
| —    | —    |   | 30    |   |
|      |      |   | 120   |   |
| —    | —    |   | 1 200 |   |
| 0,3  | 13   |   | —     |   |
| — s  | —    |   | 10    |   |
|      |      |   | 50    |   |
|      |      |   | 5     |   |

## Продолжение

| Наименование продукта                                      | В,<br>Количество витаминов<br>PP | B <sub>2</sub> | С     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| Смородина белая .....                                      | 0                                |                | 5     |
| » красная .....                                            |                                  |                | 30    |
| » черная .....                                             | 0,7                              |                | 300   |
| Черника .....                                              | Следы                            |                | 5     |
| Шиповник сушеный красный ..                                | 5                                | 0,02           | 1 500 |
| » темнофиолетовый ..                                       | 0                                |                | 100   |
| Яблоки антоновка и титовка ..                              |                                  |                | 30    |
| » разные .....                                             | 0,1                              | 0,05           | 0,05  |
|                                                            |                                  |                | 0,5   |
| 9. Плодоовощные консервы                                   | 0,5                              |                |       |
| Абрикосы, компот в жестянках                               | 1,3                              |                |       |
| Баклажанная икра в жестянках                               | 0,5                              |                | 10    |
| Горошек зеленый в жестянках                                | 2,8                              |                |       |
| Кабачконан икра в жестянках                                |                                  |                |       |
| Перец фаршированный в же                                   | 4                                |                | 15    |
| стянках .....                                              | 1,2                              |                | 10    |
| Томатный кетчуп в бутылках                                 | 1,3                              |                | 50    |
| Томат-паста в жестянках                                    | 1                                |                | 30    |
| » развесная . . .                                          | 0,5 2                            |                | 10    |
| Томат-пюре развесной .                                     | 0 0                              |                | 10    |
| Томатный сок в бутылках                                    |                                  |                | 20    |
| Шпинат-пюре в жестянках                                    |                                  |                | 3     |
| Яблочное повидло . . .                                     |                                  |                | 1,5   |
| Яблочный соус .....                                        |                                  |                |       |
| 10. Листья дикорастущих и<br>некоторых культурных растений |                                  |                |       |
| Береза .....                                               |                                  |                | 200   |
| Борщевик (онбирикун)                                       |                                  |                | 130   |
| Вика .....                                                 |                                  |                | 200   |
| Виноград .....                                             |                                  |                | 150   |
| Земляника .....                                            | 15                               |                | 150   |
| Ирис .....                                                 | 10                               |                | 300   |
| Кипрей (Иван-чай) . .                                      |                                  |                | 120 7 |
| Кислица .....                                              | 10                               |                | 0 120 |
| Клевер .....                                               |                                  |                | 220   |
| Клубника .....                                             |                                  |                | 100   |
| Крапива .....                                              | 10                               |                | 150   |
| Липа .....                                                 |                                  |                | 225   |
| Люцерна (сипни) . . .                                      |                                  |                | 150 1 |
| Малина .....                                               | 10                               |                | 100   |
| Орех грецкий .....                                         |                                  |                | 150   |
| Петрушка .....                                             |                                  |                | 250   |
| Смородина черная . .                                       | 8                                |                | 150   |
| Хмель .....                                                |                                  |                | 60    |
| Щавель .....                                               |                                  |                |       |
| 11. Хвоя                                                   |                                  |                |       |
| Кедр — лето ....                                           |                                  |                | 150   |
| » вима . . .                                               |                                  |                | 275   |
| Лиственница — лето                                         |                                  |                | 150   |
| » зима                                                     |                                  |                | 250   |
| Сосна и ель - лето                                         |                                  |                | 70    |
| , » » зима .                                               |                                  |                | 220   |

## Продолжение

| Наименование продукта                                               | В,<br>Количество витаминов<br>PP |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12. Разное                                                          |                                  |
| Гривы сухие .....                                                   |                                  |
| Дрожжи сухие пекарские . . .                                        |                                  |
| » » пивные . . . .                                                  | 40                               |
| » пивные свежие . . . .                                             |                                  |
| 13. Содержание витамина С<br>в некоторых соках, джемах,<br>вареньях | 44, 5                            |
| Апельсинный сок .....                                               |                                  |
| » » после года                                                      |                                  |
| хранения .....                                                      | 27, 4                            |
| Виноградный сок .....                                               |                                  |
| Вишневый сок .....                                                  | 4, 18                            |
| Клюквенный сок .....                                                |                                  |
| Мандариновый пастеризован                                           |                                  |
| ный сок .....                                                       | 15                               |
| Мандариновый пастеризованный сок                                    |                                  |
| после года хранения                                                 | 2, 4                             |
| Мандариновое варенье . . .                                          | 8, 2                             |
| Мандариновый джем .....                                             | 5                                |
| Персиковое варенье                                                  |                                  |
| Черносмородиновый сок консер-                                       |                                  |
| вированный с сахаром . . .                                          | 35, 2                            |
| Черносмородиновый сироп кис                                         |                                  |
| лый .....                                                           | 47, 8                            |
| Черносмородиновый сироп слад                                        |                                  |
| кий .....                                                           | 38, 2                            |
| Черносмородиновый сироп-джем                                        | 83, 5                            |
| Черная смородина, заморожен                                         |                                  |
| ная с сахаром (через 5 меся                                         |                                  |
| цев хранения) .....                                                 | 92-132                           |
| 14. Сохранность витамина С<br>в готовых блюдах и полу               |                                  |
| фабрикатах (в %)                                                    |                                  |
| Капуста вареная вместе с от                                         |                                  |
| варом .....                                                         | 50                               |
| Капуста, тушенная 1 час . . .                                       | 15                               |
| Щи, простоявшие на горячей                                          |                                  |
| плите 3 часа .....                                                  |                                  |
| Щи такие же, но подкисленные                                        | 20                               |
| Щи из кислой капусты, варенные в                                    | 50                               |
| течение часа . . . .                                                |                                  |
| Борщ украинский . . . . .                                           | 50                               |
| Картофель вареный в кожуре                                          | 70                               |
| » » очищенный                                                       | 75                               |
| » сырой очищенный,                                                  | 60                               |
| пролежавший сутки в воде                                            |                                  |
| Картофель мелко нарезанный                                          | 80                               |
| жареный .....                                                       |                                  |
| Картофельное шоро .....                                             | 35                               |
| Картофельный суп .....                                              | 20                               |
| » • ' » простоявший па                                              | 50                               |
| горячей плите 2 часа                                                |                                  |
| Морковь отварная .....                                              | 30                               |
|                                                                     | 40                               |

# СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ<sup>1</sup>

(в миллиграммах на 100 г продуктов)

Наименование продуктов

| N<br>в ;п                                     | Фосфор | Кальций | Железо  |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|
| I. Мука, хлеб, крупы                          |        |         |         |
| Хлеб ржаной черный .                          | 148    | 30      | 1,6     |
| » пшеничный Оелый                             | 93     | 27      | 0,9     |
| Мука соевая .....                             | 1 530  | 328     | 8       |
| » картофельная . Крупа гречневая . .          | 125    | 21      | 0,8     |
| » ячневая .....                               | 226    | 39      | 1,2     |
| » овсяная .....                               | 181    | 20      | 2       |
| Пшено .....                                   | 392    | 69      | 3,8     |
| Рис .....                                     | 327    | 14      | 9       |
| 10 Макароны .....                             | 96     | 22      |         |
| 11 Горох .....                                | 144    | 84      | 5,7 8,6 |
| 12 Чечевица .....                             | 400    | 107     | 7,9 7,9 |
| 13 Бобы .....                                 | 438    | 60      |         |
| 14 Фасоль .....                               | 471    | 60      |         |
|                                               | 475    | 132     |         |
| II. Мясные, рыбные в Моаолjo-япчные продукты  |        |         |         |
| 15 Говядина Баранина Свиная . Печень . Язык . | 162    | 9 15    | 2,2     |
| 16 . Судак . .                                | 374    | 23 42   | 2       |
| 17 Саз .                                      | 231    | 27 17   | 0,3     |
| 18 Сельдь .....                               | 577    | 25 26   | 38 0,8  |
| 19 Треска .....                               | 114    | 39 73   | 0,4 0,3 |
| 20 Лосось .....                               | 126    | » 15    | 0,2 0,в |
| 21 Масло коровье (сливочное и то              | 213    | 120     |         |
| 22 пленое) .....                              | 220    | 300     |         |
| 23 Молоко коровье свежее .....                | 202    | 86      |         |
| 24 » егущенное .....                          |        | 885     |         |
| 25 Сливки .....                               | 17     | 33      |         |
| Сыр.....                                      | 93     |         |         |
| 26 Яйца (1 шт.).....                          | 235    |         |         |
| 27                                            | 67     |         |         |
| 28                                            | 650    |         |         |
| 29 III. Овощи, грибы и бахчевые               |        |         |         |
| 30                                            | 43 75  | 10 57   |         |
| 31 Картофель .....                            | 29     | 45 48   |         |
| 32 Капуста свежая . . » квашеная . .          | 124 33 | 25 29   |         |
| 33 Морковь .....                              | 123 26 | 13 9 9  |         |
| 34 Свекла .....                               | 22 29  |         |         |
| 35 Лук репчатый . . .                         | 30     |         |         |
| 36 Огурцы .....                               |        |         |         |
| 37 Помидоры красные                           |        |         |         |
| 38 Баклажаны . . .                            |        |         |         |
| 39 Репа.....                                  |        |         |         |
| 40                                            |        |         |         |

<sup>1</sup> ----- I Из книги Я. Г. Полячек «Состав пищевых продуктов а их калорий цость», Медгиз, 1948,

в»

## Продолжение

| п/п | Наименование продуктов | Фосфор | Кальций | Железо |
|-----|------------------------|--------|---------|--------|
| 1   | 2                      | з 1    | 4       | 5      |
| 41  |                        | 82     | 37      | 1,0    |
|     |                        | 22     | 16      |        |
|     |                        | 32     | 33      |        |
| 42  |                        | 126    | 50      | 0,7    |
| 43  |                        | 49     | 62      | 0,5    |
| 44  |                        | 81     | 13      | 0,4    |
| 45  |                        | 15     | 16      | 0,6    |
| 46  |                        | 41 2   | 7 11    |        |
| 47  |                        | 10     | 6       |        |
| 48  |                        | 11     | 13      |        |
| 49  |                        | 17     | 17      |        |
| 50  |                        | 23     | 49      |        |
| 51  | IV. Фрукты и ягоды     | 27     | 12      |        |
|     |                        | 95     | 14      | 0,4    |
|     |                        | 21     | 15      |        |
|     |                        | 22     | 18      |        |
|     |                        | 25     | 64      |        |
| 52  |                        | 30     | 42      |        |
| 53  |                        | 132    | 128     |        |
| 54  |                        | 44     | 16      | 0,5    |
| 55  |                        | 98     | 30      | 0,3    |
| 56  |                        | 12     | 24      | 0,7    |
| 57  |                        | 41     | 34      | 0,3    |
| 58  |                        | 35     | 20      | 0,8    |
| 59  |                        | 30 8   | 34      | 0,5    |
| 60  |                        | 16     | 36      | 0,5    |
| 61  |                        | 22     | 4       | 0,5    |
| 62  |                        | 19     | 92      |        |
| 63  |                        | 455    | 112     |        |
| 64  |                        | 709    | 500     |        |
| 65  |                        |        |         |        |
| 66  |                        |        |         |        |
| 67  |                        |        |         |        |
| 68  |                        |        |         |        |
| 69  | V. Прочие продукты     |        |         | 0,7    |
| 70  |                        |        |         | 2,7    |
| 71  |                        |        |         | 2,7    |
| 72  |                        |        |         | 4,2    |

## СОДЕРЖАНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ В ПРОДУКТАХ

(в миллиграммах на 100 г продукта)

| Мясо и мясные продукты |                     |                           |     |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-----|
| Почки.....             | 320                 | Курица .....              | 140 |
| Гусь.....              | 200                 | Телятина (в среднем) .... | 130 |
| Баранина.....          | 170                 | Говядина (в среднем) .... | 110 |
| Индийка .....          | 170                 | Свинина .....             | 100 |
| Утка .....             | 140                 | Кролик .....              | 84  |
| Рыба                   |                     |                           |     |
| Треска ,               | Щука .....          | 300                       | 92  |
| Навага                 | Кари .....          | 160                       | 86  |
| Окунь ,                | Судак . . ; .....   | 100                       | 81  |
|                        | Яйца (без скорлупы) |                           |     |
|                        | Белок .....         | 310                       |     |
|                        | Желток .....        | 46                        |     |
|                        | Цельное яйцо .....  | 210                       |     |

|                                 |                      |     |
|---------------------------------|----------------------|-----|
| Молоко и моаочные продукты      |                      |     |
| Сливочное масло (несоленое) 690 | Простокваша .....    | 165 |
| Свежий творог.....250           | Молоко коровье ..... | 160 |
| Сметана.....170                 | Сливки .....         | 130 |
| Крупа и мука                    |                      |     |
| Макароны, белая мука . . . 120  | Овсянка.....         | 38  |
| Крупа манная .....              | Рис .....            | 3   |
| Овощи и гриЕы                   |                      |     |
| Сельдерей.....250               | К ртофель .....      | 82  |
| Шпинат.....210                  | Редис .....          | 71  |
| Красная капуста.....165         | Спаржа .....         | 69  |
| Салат-латук .....               | Свекла .....         | 58  |
| Редька .....                    | Мерковь.....         | 55  |
| Щавель.....112                  | Щетная капуста ..... | 48  |
| Бобы зеленые .....              | Шампиньоны .....     | 41  |
| Капуста белокочанная ... 92     | Белые грибы.....     | 36  |

НОРМА ВЫХОДА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 100 г  
ПРОДУКТА БРУТТО (или согласно

|                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| приведенным раскладкам) * в граммах                                                                                                                                   |       |
| 1. Баранина вареная без костей .....                                                                                                                                  | 46    |
| 2. » тушеная для рагу .....                                                                                                                                           | 60    |
| 3. » жареная без костей .....                                                                                                                                         | 45—46 |
| 4. Балык белорыбичи .....                                                                                                                                             | 76    |
| 5. Белорыбича разварная (без кости) .....                                                                                                                             | 55—56 |
| 6. » жареная миньер (филе).....                                                                                                                                       | 48    |
| 7. Биточки рисовые (рис 35 г, вода 95 г, сахар 3 г, яйцо 5 г, су-<br>хари 5 г, жир 6 г).....                                                                          | 123   |
| 8. Блины (мука пшеничная 70 г, молоко 105 г, дрожжи 1,4 г,<br>яйцо 16 г, масло топленое 10 г, сахар 10 г, соль 1,4 г)                                                 | 160   |
| 9. Брюква пассерованная .....                                                                                                                                         | 60    |
| 10. » ' тушеная.....                                                                                                                                                  | 62—63 |
| 11. Ветчина вареная (рулет).....                                                                                                                                      | 88    |
| 12. » » (окорок с кожей).....                                                                                                                                         | 73    |
| 13. » жареная .....                                                                                                                                                   | 66    |
| 14. Голубцы мясные (капуста 200 г, мясо 130 г, рис 16 г, лук<br>зеленый 20 г, масло сливочное 10 г, соль 4 г, неявен но<br>вкусу, соус сметашно-морковный 50 г) ..... | 430   |
| 15. Горох отварной .....                                                                                                                                              | 210   |
| 16. Грудинка копченая с костью (уварка).....                                                                                                                          | 74    |
| 17. Гусь жареный.....                                                                                                                                                 | 37—38 |
| 18. Запеканка картофельная с мясом (мнео 100 г, лук 20 г, жир<br>10 г, картофель 300 г, сухари 5 г, морковь 5 г, петрушка 5 г,<br>соль 3 г) .....                     | 230   |
| 19. Зразы мясные рубленые (мясо 100 г, хлеб 18 г, вода 22 г, яйцт<br>10 г, лук пассерованный 13 г, зе те нь 1,5 г, сухари 8 г)                                        | 123   |
| 20. Капуста свежая (или квашеная) тушеная (капуста 200 г, мор-<br>ковь 30 г, томат-пюре 5 г, лук репчатый 5 г, мука пшенич<br>ная 5 г, специи) .....                  | 148   |
| 21. Капуста цветная, запеченная под молочным соусом (капуста<br>цветная 300 г, молоко 100 г, мука пшеничная 10 г, сыр 4 г,<br>сухари 3 г, специи) .....               | 240   |
| 22. Капуста белая тушеная .....                                                                                                                                       | 63    |
| 23. » цветная второго сорта.....                                                                                                                                      | 55    |
| 24. » квашеная тушеная .....                                                                                                                                          | 61—62 |
| 25. Кабачки, фаршированные мясом (кабачки 200 г, мясо 100 г,<br>лук Юг, жир 5 г, сметана 10 г, мукапшеничная 5г, специи) 270 — 272                                    |       |
| 26. Кабачки жареные .....                                                                                                                                             | 62—63 |

-Тарника раскладок для предприятий общественного питания, Госторгиздат, 1940 и 1942.

|                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 27. Картофель жареный .....                                                                                           | 44—50   |
| 58. » отварной.....                                                                                                   | 68—70   |
| 29. » # молодой .....                                                                                                 | 85      |
| 30. « шоре (нартофе.йь 200 г, молоко 30 г).....                                                                       | 175     |
| 31. Каша гречневая рассыпчатая .....                                                                                  | 210     |
| 32. » » вязкая .....                                                                                                  | 300     |
| 33. » » полз вязкая .....                                                                                             | 400     |
| 34. » пшенная рассыпчатая .....                                                                                       | 250     |
| 35. » » вязкая .....                                                                                                  | 300     |
| 36. » » полувязкая .....                                                                                              | 4 00    |
| 37. » рисовая рассыпчатая.....                                                                                        | 280     |
| 38. » » вязкая .....                                                                                                  | 350     |
| 39. » » полувязкая .....                                                                                              | 450     |
| 40. » » полужидкая .....                                                                                              | 600     |
| 41. » манная вязкая .....                                                                                             | 350     |
| 42. » » полувязкая .....                                                                                              | 400     |
| 43. » » полужидкая .....                                                                                              | 550     |
| 44. » овсяная вязкая.....                                                                                             | 3иО     |
| 45. » » полувязкая .....                                                                                              | 4 00    |
| 46. » ячневая вязкая.....                                                                                             | 350     |
| 47. » » полувязкая .....                                                                                              | 450     |
| 48. Кета малосольная . . . . .                                                                                        | 65      |
| 49. Килька в банках .....                                                                                             | 45      |
| 50. Колбаса вареная .....                                                                                             | 98      |
| 51. » жареная . . . . .                                                                                               | 88      |
| 52. Клубника .....                                                                                                    | 85      |
| 53. Корейка копченая .....                                                                                            | 80      |
| 54. Котлеты мясные рубленые (мясо 100 г, хлеб 18 г, сухари 7 г,<br>вода 22 г, жпр 5 г) .....                          | 98      |
| 55. Котлеты из куриного мяса рубленые (курица 100 г, хлеб 10 г, .<br>молоко 14 г, яйцо 5 г, сухари 5 г, жпр 5 г)..... | 59—60   |
| 56. Котлеты свиные рубленые (свинина 100 г, хлеб 21 г, вода 25 г,<br>сухари 8 г, жир 5 г) .....                       | 111     |
| 57. Котлеты свиные отбивные с костью.....                                                                             | 88—89   |
| 68. » из свежего судака рубленые (свежий судак 100 г,<br>хлеб белый 15 г, молоко 18 г, сухари 6 г, масло 5 г) ...     | 79—60   |
| 59. Котлеты картофельные (картофель 200 г, мука 5 г, жир 8 г,<br>соус 30 г).....                                      | 165—170 |
| 60. Котлеты телячи отбивные с реберной костью .....                                                                   | 81—82   |
| 61. » рубленые (мясо 100 г, хлеб 12 г, молоко 15 г,<br>сухари 5 г) .....                                              | 64—65   |
| 62. Котлеты рубленые из дичи (дичь 100 г, хлеб 8 г, молоко 9 г,<br>яйцо 2 г, масло 3 г, сухари 5 г).....              | 52      |
| 63. Крупеник (крупа гречневая 40 г,, вода 120 г, творог 25 г,<br>яйцо 5 г, сухари 2 г, жир 2 г, сметана 5 г) .....    | 120     |
| 64. Куры отварные первого сорта .....                                                                                 | 52      |
| 65. » » второго » .....                                                                                               | 50      |
| 66. » жареные .....                                                                                                   | 46—47   |
| 67. Лимонный сок .....                                                                                                | 33      |
| 68. Лец непластованный кусками в вареном виде .....                                                                   | 50      |
| 69. » в жареном виде.....                                                                                             | 54      |
| 70. » жареный миньер (филе).....                                                                                      | 43—44   |
| 71. Лук репчатый пассероваша.й .....                                                                                  | 62      |
| 72. » зеленый* .....                                                                                                  | 8J)     |
| 73. Макаронник с мясом и яйцом (макароны 40 г, мясо 50 г,<br>яйцо 1 шт., лук 10 г, сухари 5 г, жир 5 г, специи) . . . | 155     |
| 74. Макароны отварные .....                                                                                           | 250     |
| 75. Мозги жареные (миньер) (мозги 100 г, мука пшеничная 4 г,<br>жир 5 г) .....                                        | 63—64   |
| 76. Морковь молодая с ботвой.....                                                                                     | 50      |
| 77. » сырая .....                                                                                                     | 80      |
| 78. » пассерованная- .....                                                                                            | 54—55   |
| 79. » тушеная .....                                                                                                   | 66—67   |
| 80. Мясо вареное (средней упитанности без костей) .....                                                               | 46—47   |
| 81. Мясо тушеное кусочками для гуляша, беф-строгапов, азу .....                                                       | 47—48   |
| 82. Мясо жареное кусками для ростбифа, первый сорт . . .                                                              | 46—47   |
| 83. Навага жареная. (мука 5 г).....                                                                                   | 54—60   |
| 84. Огурцы свежие чищенные .....                                                                                      | 80      |
| 85. » соленые чищенные .....                                                                                          | 80      |

|                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 88. Огурцы (иа очистку сердцевины).....                                                                                                 | 40      |
| 87. Осетрина вареная (звенoм).....                                                                                                      | 50—51   |
| 88. » в жареном виде (мнньер).....                                                                                                      | 51—52   |
| 89. » » » » (фри).....                                                                                                                  | 63—64   |
| 90. Оладьи (мука пшеничная 40 г, вода 80 г, дрожжи 1 г, жир 5 г).....                                                                   | 75      |
| 91. Пастернак пассерованный.....                                                                                                        | 47—48   |
| 92. Печенка жареная (без соуг.).....                                                                                                    | 75—76   |
| 93. Петрушка (зелень).....                                                                                                              | 74      |
| 94. Пирожки с мяссm (мука S0 г, мнсо 40 г, лук 10 г, масло 5 г, сахар 1,5 г, яйцо 7 г, дрожжи 0,5 г, вода 15 г).....                    | 65—70   |
| Плов из баранины (баранина 100 г, рис 40 г, лук 10 г, жир 5 г, специи). . . . .                                                         | 218     |
| 96. Помидоры свежие.....                                                                                                                | 85      |
| 97. » жареные.....                                                                                                                      | 53—54   |
| 98. Поросенок жареный.....                                                                                                              | 56      |
| 99. Рагу из баранины (баранина 100 г, морковь 2и г, луп ■■■, петрушка 5 г, томат-пюре 10 г, мука пшеничная 5 г, жир , 5 г, специи)..... | 160     |
| 100. Ромштекс, первый сорт (яйцо 4 г, сухари 10 г).....                                                                                 | 62—63   |
|                                                                                                                                         | 57—58   |
|                                                                                                                                         | 75      |
|                                                                                                                                         | 50      |
| 104. Редька.....                                                                                                                        | 70      |
| 105. Рулет мясной (мясо 100 г, хлеб 15 г, вода 18 г, сухари 3 г, яйцо 2 г).....                                                         | 98—99   |
| Рулет картофельный с луком (картофель 200 г, яйцо 10 г, .....                                                                           | 180-183 |
| 106. Рулет КРiрич».....                                                                                                                 |         |
| лук 20 г, жир 8 г, сове 30 г).....                                                                                                      | 67—72   |
| 107. Салат (зелень).....                                                                                                                | 90      |
| 108. Сардели жареные.....                                                                                                               | 91      |
| 109. Сардины в банках.....                                                                                                              | 72      |
| 110. Семга малосольная.....                                                                                                             | 70      |
| 111. Сельдь соленая без кожи и внутренностей.....                                                                                       | 50      |
| 112. » филе.....                                                                                                                        | 51      |
| 113. Свинина вареная без костей.....                                                                                                    | 57—58   |
| 114. » жареная без костей.....                                                                                                          | 73      |
| 115. Свекла вареная.....                                                                                                                | 47—48   |
| 116. » пассерованная.....                                                                                                               | 63—64   |
| 117. » тушеная.....                                                                                                                     | 46—47   |
| 118. Стерлядь припущенная.....                                                                                                          | 46—47   |
| 119. Судак вареный с реберной костью и кожей (непластованный).....                                                                      | 50—51   |
| 120. Судак жареный (мпньер)+мука (4 г).....                                                                                             | 40      |
| 121. » в вареном виде.....                                                                                                              | 72—73   |
| 122. » фаршированный (судак 100 г, хлеб 10 г, мол оно 12 г, лук 13 г, масло 6 г, чеснок 1 г).....                                       | 94      |
| 123. Сыр голландский.....                                                                                                               | 92      |
| 124. » швейцарский.....                                                                                                                 | 75      |
| 125. Сырники из творога (творог 75 г, мука пшеничная 10 г, яйцо 10 г, жир 5 г).....                                                     | 44      |
| 126. Телятина жареная (задняя нога, корейка).....                                                                                       | 47—48   |
| 127. » вареная (второй сорт).....                                                                                                       | 110     |
| 128. Тефтели (мясо 100 г, хлеб 15 г, вода 18 г, лук 12 г, мука 3 г, жир 5 г).....                                                       | 70      |
| 129. Тыква отварная.....                                                                                                                | 54—55   |
| 130. » жареная.....                                                                                                                     | 64      |
| 131. Хрен.....                                                                                                                          | 47—48   |
| 132. Цыплята вареные.....                                                                                                               | 43—44   |
| 133. » жареные.....                                                                                                                     | 210     |
| 134. Фасоль отварная.....                                                                                                               | 86—87   |
| 135. ПДпиг свиной соленый (ужарка).....                                                                                                 | 37      |
| 136. Шпинат вареный.....                                                                                                                | 41      |
| 137. Щука жареная, мнньер (филе).....                                                                                                   | 56      |
| 138. » отварная (на кости).....                                                                                                         | 80      |
| 139. » фаршированная (щука 100 г, хлеб белый 11 г, мо- локо 13 г, лук 17 г, масло 7 г, чеснок 1 г).....                                 | 63—64   |
| 140. Язык бычий вареный.....                                                                                                            | 70      |
| 141. ЯОлопк (на очистку сердцевину).....                                                                                                |         |

ГЛАВА VI  
ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

АБСЦЕСС, ГНОЙНИК (ABSCESSUS). Причина — развитие в глубине тканей гноеродных бактерий, стафилококков, стрептококков, кишечной палочки и т. д., проникших "срез небольшие повреждения и трещины кожи или слизистой или при переносе с током лимфы и крови. Ткани в области очага подвергаются гнойному расплавлению вследствие выделения из поврежденных тканей лейкотоксина (Менкин). Вокруг скопления гноя, которое должно рассматриваться «как реакция организма против „вредного деятеля" (И. И. Мечников), образуется грануляционный вал, ограничивающий гной от здоровых тканей. Изменения в тканях зависят от расстройств функции нервной системы и имеют рефлекторный характер.

Симптомы и течение. Общие лихорадочные явления: головные боли, разбитость, отсутствие аппетита, i мпература. Абсцесс дает значительные колебания температуры, особенно через 5—7 дней после начала процесса, т.е. когда происходит скопление гноя: 37° с десятиыми утром, 38—39° с десятиыми вечером. При поверх-постных абсцессах отмечают припухлость, болезненность на ограниченном участке, местное повышение температуры, красноту, напряжение кожи, инфильтрат при пальпации.

При глубокоm расположении о скоплении гноя узнают по общим явлениям: высокой температуре (особенно с утренними падениями и подъемами по вечерам на 5—7-й день болезни), иногда по размяг чению центра инфильтрата. При более поверхностных процессах появляется отек над абсцессом (образование ямочки при надавлива нии пальцем). При скоплении гноя определяется зыбление (флюк туация). Инфекция из гнойника может распространиться по лимфа тическим сосудам, вызывая лимфангоит (воспаление лимфатических сосудов), лимфаденит (воспаление лимфатических узлов), или же по кровеносной системе, переходя в общую гнойную инфекцию (сепсис).

Лечение. Обеспечить покой больному и пораженному органу; тепло в виде согревающих компрессов и припарок или применение сухого тепла (грелки, соллюкс и т. д.). Пенициллин внутримышечно. Возможно введение пенициллина в полость абсцесса после его пункции и отсасывания гноя. Стрептоцид по 1,0 четыре раза в день. При образовании скопления гноя необходимо оперативное вмешательство (разрез) и последующее лечение гнойной раны.

АБСЦЕСС АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ (ABSCESSUS APPEN- CULARIS). Распространение воспалительного процесса за пределы червеобразного отростка дает при отграничении от свободной брюшной полости аппендикулярный инфильтрат. Возможно обратное раз-

витие процесса—рассасывание или формирование абсцесса. Локализация аппендикулярного абсцесса — в правой подвздошной области, в малом тазу, позади слепой кишки, под печенью, между кишечными петлями. После удаления отростка могут быть остаточные абсцессы.

**Симптомы и течение.** Высокая температура, боли, ограничение или увеличение инфильтрата, лейкоцитоз. При тазовом абсцессе — учащение стула, тепеэмы, слизь в испражнениях. Абсцесс может вскрыться в свободную брюшную полость, в кишечник, мочевые пути, влагалище. Осложнения — общая гнойная инфекция, перитонит, абсцессы печени, поддиафрагмальный абсцесс (см. и другие гнойные процессы).

**Лечение.** Строгий постельный режим, пенициллин, сульфаниламидные препараты, лед на живот. Диета: суп, жидкие каши, вареные овощи, компоты. На 7—8-й день для ускорения формирования абсцесса — грелки, горячие (40°) микроклизмы из ромашки (3,0 ромашки на один стакан воды) 3—5 раз в день.

Слабительные и наркотики противопоказаны.

При формировании гнояника — оперативное лечение.

**АБСЦЕСС МОЗГА (ABSCUSSUS CEREBRI).** Развивается вследствие распространения гнойной инфекции из существующих у больных гнойных заболеваний (например, головы, лица, среднего уха, лобных и челюстных пазух и т. д.). Гнойники могут развиваться также в результате перехода нагноения из раны и заноса инфекции в вещество мозга при огнестрельном ранении или при открытых переломах черепа.

**Симптомы и течение.** Головная боль, головокружение, беспокойное состояние, боли при поколачивании по определенному участку головы. В дальнейшем присоединяется рвота, тошнота, затемнение сознания, бред, коматозное состояние. Гнойники мозга могут быть одиночные и множественные (при метастазах), острые и хронические. Гнойники ушного происхождения развиваются преимущественно в височных долях и мозжечке, гнойники носового происхождения — в лобных долях. Размеры гнойников — от горошины до крупного яблока и больше. Если гнойник ограничивается от здоровой ткани, он может перейти в хронический (вокруг гнойника образуется сумка или капсула) и существовать от нескольких месяцев до нескольких лет.

**Распознавание.** Наиболее важны очаговые признаки: гнойники в двигательной зоне вызывают судороги, парезы, параличи; гнойники мозжечка сопровождаются головокружением и расстройством походки.

**Лечение.** Трепанация черепа с последующим вскрытием гнойника. Пенициллин. Уход за больным состоит в предоставлении ему покое, придании горизонтального положения со слегка приподнятой головой; лед на голову. Необходимо наблюдать за больным в состоянии бреда. При беспокойстве — наркотики (морфин), при запорах — слабительные или клизмы.

**АБСЦЕСС ПЕЧЕНИ (ABSCUSSUS HEPATIS).** Наиболее часто является результатом осложнения острого гнойного аппендицита, воспалительных заболеваний желчных путей и заболеваний других

органов брюшной полости, а также септических и инфекционных заболеваний, амёбной дизентерии. Наблюдается в виде множественных и одиночных гнойников. Гнойники печени могут вскрываться в свободную брюшную полость, под диафрагму, между ней и печенью, в полость плевры, легкое и даже сердечную сорочку.

**Симптомы и течение.** Плохое самочувствие, похудание, желтушность склер и серовато-желтый цвет лица. Лихорадка с ознобом. Часто лейкоцитоз (от 8 000 до 10 000).

Жалобы на чувство напряжения и боли в области печени с отдачей в плечо. Печень болезненна и увеличена; диафрагма стоит высоко и иногда куполообразно выпячивается. При глубоком расположении гнойника местные симптомы могут отсутствовать. При образовании в абсцессе газа распознаванию помогает рентгенологическое исследование. Предсказание при абсцессах печени серьезное.

**Лечение** оперативное. При абсцессах амёбного происхождения — лечение эметином.

Rp. Sol. Emetini hydrochlorici 5% 1,0 Sterilis! DS. На 1 инъекцию 2 раза в сутки в течение 3 дней

**АБСЦЕСС ПОДДИАФРАГМАЛЬНЫЙ (ABSCUSSUS SUBDIAPHRAGMATICUS).** Наблюдается как осложнение после воспалительных заболеваний внутренних органов (червеобразного отростка, желудка, печени и т. п.), а также при повреждениях. Инфекция проникает по лимфатическим путям или непосредственно в поддиафрагмальное пространство (например, при повреждениях и ранениях).

**Симптомы и течение.** Абсцесс может возникнуть внезапно или образование его идет с мало заметными симптомами. Температура повышается и принимает ремиттирующий характер. Субъективные жалобы не характерны; некоторые больные жалуются на боли и чувство давления в верхней части живота с отдачей в спину, при расположении гнойника в соседстве с париетальной брюшиной — на тошноту, рвоту, вздутие кишечника, а при высоком положении абсцесса — на боль в груди, болезненность по ходу кожных межреберных нервов и одышку. В полости плевры может определяться жидкость. При переходе инфекции на плевру возникает гнойный плеврит — эмпиема.

**Распознавание.** Резкие колебания температуры, лейкоцитоз (8 000—10 000—12 000), особенно после тяжелого аппендицита, холецистита, перфоративных язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Обращает на себя внимание отставание при дыхании пораженной стороны и сглаживание межреберных промежутков; давление на нижние ребра и промежутки болезненно. Наиболее ценно рентгенологическое исследование\*. Пробная пункция с целью диагностики противопоказана.

**Лечение.** Вскрытие абсцесса. Пенициллин до и после операции.

**АКТИНОМИКОЗ (ACTINOMYCOSIS).** Вызывается лучистым грибом, образующим в тканях организма характерные зерна — под микроскопом определяются грибковые друзы с булавовидными

утолщениями, располагающимися в виде лучей. Вне животных организмов грибок обнаружен на злаках, на осях колосьев (даже высушенных), особенно ячменных. В организм человека грибок может проникнуть при вдыхании его вместе с воздухом во время работы — при молотье, сушке, приемке и обработке зерна, при еде зерен из сырых колосьев. Внедрение грибка происходит через полость рта и глотки (до 50% случаев), через легкие, кишечник и кожу.

**Симптомы и течение.** Воспаление в виде деревянистого, долго держащегося инфильтрата, в котором потом появляются очаги размягчения и образуются небольшие полости с распадом (гной) и свищевые ходы. В отдельных органах процесс дает своеобразную картину: например, в легких — картину гнойного бронхита, бронхопневмонии, каверн, в слепой кишке — узлы и язвы, напоминающие туберкулез или рак.

Гнойные выделения из свищей не обильны. Окраска кожи над инфильтратом при его поверхностном расположении и вокруг свища синевато багрового цвета. В выделяющемся гною иногда могут быть замечены беловатые мелкие зернышки. Наиболее типично актиномикотическое поражение, исходящее из полости рта (кариозные зубы, периодонтиты, гингивиты) и распространяющееся на наружные покровы шеи и челюсть. Может встречаться также на коже, в легких, кишечнике и почках.

**Лечение.** Наилучший метод лечения — применение активизаторов, пеницилина и переливание крови. Внутрь — йодистый калий в больших дозах; постепенно увеличивая дозу, доводят ее до 2,0—6,0 г в день, если не наступит явлений йодизма. Одновременно применяют оперативное вскрытие свищей и выскабливание очагов с последующим лечением повязками с люголевским раствором. Там, где это возможно, производят иссечение инфильтрата и даже больного органа, например, слепой кишки.

Rp. Sol. Kalii jodati 2—6% 100,0

DS. На 1 сутки столовыми ложками через равные промежутки времени на молоке «

Rp. Jodi puri 1,0 Kalii jodati 2,0 Aq. destill. 100,0

MDS. Люголевский раствор для повязок

**АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ** см. Газовая гангрена.

**АНГИОМА (ANGIOMA).** Опухоль развивается из сосудов. Встречается чаще в детском возрасте. Различают опухоли из лимфатических сосудов (лимфангиомы) и из кровеносных (гемангиомы). Гемангиомы делятся на простые, пещеристые и ветвистые. Ангиомы имеют склонность к прогрессивному росту, возможен быстрый рост (особенно у детей).

**Симптомы и течение.** Лимфангиома — безболезненная, мягкая, исчезающая при давлении припухлость, мало ограниченная, с неизменной кожей. Чаще встречается в области губ, языка, на шее. Гемангиомы простые имеют вид пятен на коже синевато-красного цвета (родимые пятна). Пещеристые ангиомы встречаются

в подкожной клетчатке, чаще в области лица, печени, состоят из губчатых полостей, наполненных кровью, просвечивают через кожу, могут изъязвляться и давать кровотечение. Ветвистые артериальные ангиомы пульсируют.

**Лечение.** У детей начинают лечение возможно раньше, не дожидаясь роста и изъязвления. Применяют оперативное лечение, введение склерозирующих веществ, рентгенотерапию, замораживание снегом угольной кислоты, электрокоагуляцию.

**АНЕВРИЗМА (РАСШИРЕНИЕ АРТЕРИИ) (ANEURYSMA).** Патологически измененная стенка сосуда, растягиваясь, образует выпячивание (истинная аневризма). При ранении артерии кровь изливается в окружающие ткани и частично свертывается, причем из этих свертков и окружающих тканей образуется стенка мешка, соединенного с сосудом и содержащего жидкую кровь (травматическая или ложная аневризма). Различают еще артерио-венозные аневризмы, при которых имеется сообщение вены с артерией.

**Симптомы и течение.** Припухлость круглой или овальной формы, соответствующая положению артерии, дающая пульсацию и шум при выслушивании. При сдавлении артерии нейтральное аневризмы пульсация исчезает, а опухоль уменьшается. По мере роста аневризмы она сдавливает вены, вызывая затруднение кровообращения, синюшность и отеки ниже аневризмы. Часто страдают нервы, что вызывает параличи и расстройство чувствительности. Вследствие истончения соседних тканей возможен разрыв аневризмы со смертельным кровотечением.

**Лечение** травматической аневризмы почти исключительно оперативное. В качестве предварительной меры для подготовки больного к операции можно применить сдавливание приводящего ствола артерии ежедневно в течение 1—2 часов: прижатие производится выше аневризмы в тех местах, где сосуд расположен более поверхностно, а в глубине может быть прижат к кости.

**АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ.** Для инфильтрационной анестезии применяют 0,5% раствор новокаина.

Rp. Novocaini 1,0

Sol. Natrii citilicati 0,9% 200,0

Sterilisetur!

DS. Для инъекции

Отдельно выписывают:

Rp. Sol. Adrenalinii 1 : 4 000- 10,0

DS. Для инъекции: 1—2 капли на 10 мл новокаина 0,5% раствора

Адреналин добавляется некоторыми хирургами по 1—2 капли на 10 мл раствора, всего не более 1,0. Может быть введено до 300—500 мл 0,5% раствора новокаина.

Для часто применяемой и имеющей большие преимущества местной инфильтрационной анестезии по методу ползучего инфильтрата Вишневского применяется 0,25% раствор новокаина на рин-геровском растворе.



Rp. Natrii chlorati 1,2 Kalii chlorati  
0 015 Calcii chlorati 0,025  
Novocaini 0,5 Aq. destill. 200,0  
Sterilisetur! DS. Для местной  
анестезии

Употребляется раствор в подогретом виде. Может быть введено 500 мл и более.

Для регионарной анестезии (перинеуральной) применяют 1—2% раствор новокаина в количестве 20—40 мл.

Rp. Sol. Novocaini 1% 40,0  
Sterilisetur! DS. Для  
инъекции

Для анестезии слизистых путем смазывания применяют 5% раствор кокаина или 2% раствор дикаина.

Rp. Sol. Dicaini 2% 30,0 Sterilisetur!  
DS. Для смазывания слизистых

Дикаин токсичнее кокаина, обладает в 10 раз более сильным действием, не разлагается от кипячения и может долго сохраняться в растворе.

**АНЕСТЕЗИЯ СПИННОМОЗГОВАЯ.** Для проведения такого обезболивания применяют острую, средней толщины иглу длиной 10—12 см с круто заточенным острием и раствор анестезирующего вещества. Чаще всего применяют 2—5% раствор новокаина или 0,6—0,8—1% раствор совкаина.

Применение спинномозгового обезболивания не может считаться вполне безопасным, так как иногда наблюдается остановка дыхания и падение сердечной деятельности. Поэтому при проведении этой анестезии необходимо проводить соответствующие мероприятия: впрыскивание растворов лобелина, эфедрина, кофеина, камфоры, внутривенные вливания физиологического раствора, глюкозы и переливание крови. Падение сердечной деятельности начинается обычно резким поблдением- больного, появлением тошноты, рвоты.

**АНКИЛОЗ, НЕПОДВИЖНОСТЬ В СУСТАВЕ (ANKYLOSIS).** Может наступить либо вследствие фиброзного сращения суставных концов, допускающего незначительные движения в суставе, либо в результате костного сращения. Развивается после травмы (кровоизлияние в сустав, изменения суставных поверхностей) или воспалительного процесса (гнойное и гонорройное воспаление, туберкулез сустава). При воспалительных процессах сумка сморщивается до полного исчезновения суставной щели.

**Симптомы и течение.** Неподвижность в суставе, функциональные расстройства (хромота, ограничение движений конечности), боли при нагрузке и движениях.

**Лечение.** При фиброзных анкилозах — физио-механотерапия; при костных — артропластика (образование искусственного

г\*

сустава) для восстановления движений в суставе, остеотомия (иссечение части кости) для исправления неправильного положения конечности.

**Профилактика.** Правильное лечение переломов и воспалений суставов: физиологическое положение, ранние движения, массаж, лечебная физкультура, механотерапия, трудотерапия; избегать наложения гипсовых повязок на длительные сроки.

**АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.** Для предохранения от разложения гноя в повязке, в особенности для предупреждения развития в ней личинок мух, применяют материал, пропитанный раствором сулемы и карболовой кислоты. При оставлении тампонов на значительный срок применяют мазь Вишневского или йодоформную марлю, если сильно разлагается гной (операция в области челюстей, прямой кишки, полости носа). Ее готовят следующим образом: стерильные тампоны погружают в раствор:

Rp. Jodoformii 20,0 ■  
Aetheri sulfurici 150,0  
Spiritus Vini rectificati 95° 4,0,0  
MDS. Для приготовления йодоформных тампонов

Из указанного раствора с соблюдением правил асептики тампоны переносят в пустые стерильные банки, в которых они и сохраняются до употребления.

**АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.** Азотнокислое серебро (Argentum nitricum). В твердом виде или в 10% растворе применяется для прижиганий.

Rp. Argenti nitrici 10% 5,0 " I  
DS. Для прижиганий

В растворах 1 : 1 000 и 1 : 500 применяется для промывания полостей, в особенности мочевого пузыря.

Анилиновые краски (бриллиантовая и малахитовая зелень, метилвиолет). Применяются в 1% спиртовых и водных растворах, преимущественно для обработки небольших ран и дезинфекции кожи перед операцией.

Иодная настойка (T-rae Jodi). 5—10% спиртовый раствор иода. Применяется для дезинфекции и дубления кожи кончиков пальцев рук после их мытья и для подготовки к операции кожи больного в области операционного поля. Не применяется для дезинфекции металлических инструментов, так как они от действия иода портятся. При смазывании кожи могут быть ожоги и последующее ее шелушение и даже пузыри (во избежание ожогов излишки иода снимают, протирая кожу спиртом).

Карболовая кислота (Acidum carbolicum). В очищенном виде применяется как прижигающее для смазываний слизистых оболочек при операциях на кишечнике, желчных ходах (смазывание слизистой культи пузырного протока).

Как дезинфицирующее средство применяется в 2—3—5% растворах почти исключительно для дезинфекции инструментов, которые при ее применении не портятся, кроме бужей и катетеров, покрытых лаком (полумягких). Растворяется в теплой воде.

Лизол (Lysolum). Применяется для дезинфекции режущих инструментов в 10 У<sub>0</sub> растворе, для мытья рук, перчаток и хирургического инструментария — в 2% и для промывания полостей — в 0,5% растворе.

## В

Марганцовокислый калий (Kalium hypermanganicum). Применяется при ожогах в 5% растворе и для промывания ран и полостей в 0,1—0,5% растворе, особенно при гнилостных процессах (зловонные язвы и полости). Может быть применен в растворе 0,5—1,0 : 1 000 в подогретом виде для постоянного орошения при гнойных ранах.

Перекись водорода (Hydrogenium hyperoxydatum). Применяется для промывания рая, отмачивания повязок и остановки капиллярного кровотечения в 2—3% свежем растворе.

Риванол (Rivanolum). Употребляется в растворе 0,5 : 1 000 (золотистожелтая жидкость) для промывания ран и смачивания тампонов.

Сулема (Hydrargyrum bicloratum corrosivum). Применяется в растворе 1 : 1 000, подкрашенном в розовый или синий цвет, для мытья рук, особенно для обмывания перчаток и других резиновых предметов, а также предметов, покрытых лаком (мочеточниковые катетеры, бужи, полумягкие катетеры). Для промывания ран и полостей не применяется ввиду ядовитого действия. В присутствии гноя и других содержащих белок жидкостей дает нерастворимые соединения — альбуминаты, которые не обладают дезинфицирующим действием, но могут всосаться и вызвать отравление. Инструменты от соприкосновения с растворами сулемы портятся (чернеют).

Хлорамин (Chloraminum). Применяется в 0,5—1% растворе для промывания полостей, смачивания тампонов, вводимых в рану, и при поражении стойкими ОВ.

Хлорацид (Chloracidum). Применяется для промывания и постоянного орошения ран в 2% растворе.

АНУРИЯ (ANURIA). Полное прекращение выделения мочи. (См. *Мочеиспускание расстройств*.) Наблюдается в результате острых и хронических заболеваний почек (острые и хронические нефриты, разрушение почек при гидронефрозах, туберкулезе и т. д.), а также вследствие препятствий в мочевыводящих путях (камни лоханки, мочеточников). Острая анурия наблюдается также при повреждении почек, после "операции на почке и мочевыводящих путях (рефлекторная анурия). В результате отсутствия выделения мочи у больного наступает состояние уремии (см.). При анурии мочевой пузырь мочи не содержит, что определяется катетеризацией с соблюдением самой строгой асептики.

Л е ч е н и е направлено на борьбу с основным заболеванием. При анурии в результате препятствий к выделению мочи (камни

почек, мочеточников) может потребоваться хирургическое вмешательство.

АППЕНДИЦИТ (APPENDICITIS). ВОСПАЛЕНИЕ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА СЛЕПОЙ КИШКИ. Вызывается инфекцией, которая внедряется в стенку червеобразного отростка непосредственно из полости отростка, по кровеносным и лимфатическим

путям. Развитию воспалительного процесса способствует богатая животными белками пища, застой содержимого в отростке.

При острых аппендицитах могут развиваться аппендикулярные инфильтраты, аппендикулярные абсцессы и гнойные перитониты. Воспалительный процесс, переходя с отростка на брюшину, вызывает перитонит; в полости живота появляется выпот, вначале прозрачный и стерильный, затем переходящий в гнойный, причем наибольшее скопление гноя наблюдается в дугласовом пространстве. В брюшной полости из экссудата выпадает фибрин, склеивающий отросток с кишками, салником, — образуется инфильтрат; последний может рассосаться или превратиться в гнойник. Наиболее часто гнойник располагается в правой подвздошной впадине, в малом тазу, в паху, а также позади слепой кишки, под печенью, диафрагмой и между кишечными петлями. Гнойники вскрываются в прямую кишку, во влагалище, реже наружу.

Симптомы и течение. Приступ острого аппендицита начинается внезапно появлением острой боли в правой подвздошной впадине. Иногда боль мигает больным в подложечной области, около пупка, а затем переходит в правую подвздошную область. Температура повышена (38—39°), но может быть и нормальной. Пульс соответствует температуре, но может быть учащенным, что говорит о силе инфекции и распространении процесса на брюшину. Иногда наблюдается расхождение между пульсом (частый) и температурой (нормальная или субфебрильная), указывающее на тяжесть процесса. Вначале часто бывает рвота, может быть и тошнота. В крови — лейкоцитоз, в некоторых случаях доходящий до 25 000—30 000, нейтрофилез и сдвиги влево; реакция оседания эритроцитов ускорена.

Важный симптом — мышечное напряжение при надавливании на брюшную стенку; при расположении же отростка позади слепой кишки этот признак отсутствует. На второй или третий день может быть обнаружен плотный болезненный инфильтрат.

Р а с п о з н а в а н и е аппендицита не всегда легко. Исследование живота нужно производить, последовательно пальпируя живот, начиная с левой (здоровой) подвздошной области. При аппендиците наблюдаются полон; ятельные симптомы Щоткина-Блюмборга, Ровзинга и Ситковского. При симптоме Щоткина-Блюмберга больной ощущает острую боль, если медленно надавливать на брюшную стенку и быстро отнимать палец; симптом Ровзинга — острая боль в правой подвздошной области при надавливании на нисходящую толстую кишку и продвижении руки в направлении к слепой кишке; симптом Ситковского — боль в правой подвздошной впадине усиливается при поворачивании больного на левый бок.

Аппендицит следует отличать от острого гастроэнтерита (распространенная боль в животе, мышцы не напряжены, понос); прободной язвы желудка и кишок (боль возникает внезапно в подреберье, как бы от удара кинжалом, сопровождается шоком и напряжением мышц; важен анамнез заболевания); заболеваний почек (почечные камни, мочеточниковые камни); паранефрита (при ретро-гекальном расположении отростка). При симптомах местного перитонита следует иметь в виду острое воспаление правых придатков,

внематочную беременность (бледность и малый пульс, напряжение мышц слабо выражено), инвагинация (схваткообразные боли без напряжения мышц, прощупывается опухоль, кровь и слизь из заднего прохода), пневмококковый перитонит у детей (тяжелое состояние, понос, цианоз, очень высокая температура, многократная рвота) и крупозное воспаление легких (особенно при центрально расположенном фокусе).

Осложнения: гнойники вокруг отростка, прободения, перитонит, а также гнойник дугласова пространства, тромбофлебит воротной вены.

Гнойник дугласова пространства: боль над лобком, вздутие живота, высокая температура, высокий лейкоцитоз, учащенный стул, жжение, понос, цианоз, очень высокая температура, многократная рвота) и крупозное воспаление легких (особенно при центрально расположенном фокусе).

Лечение. Быстрая доставка больного в больницу для срочной операции. Все больные с острым аппендицитом подлежат немедленной госпитализации для операции за исключением больных с инфильтратами. Во время острого приступа необходимо особенно остерегаться назначения слабительного, так как оно способствует распространению процесса, а также употребления наркотиков, затемняющих картину: при их применении можно пропустить важные осложнения (перфорацию, перитонит).

При выжидательном лечении — в первые дни строгая голодная диета: пенициллин, сульфаниламидные препараты, салол с белладонной,

Rp. 'Saloli 0,5  
Extr. Belladoimae 0,015  
M. f. p. D. t. d. N. 12  
S. По 1 порошку 3 раза в сутки

«

При образовании инфильтрата — покой, постельное содержание, нераздражающая, механически щадящая диета; местно пузырь со льдом до падения температуры, пенициллинотерапия, внутрь салол с белладонной, сульфаниламиды. При продолжительной лихорадке (более 6—7 дней) со значительными вечерними подъемами температуры, говорящей о гнойном процессе, и при отграничении инфильтрата — вскрытие гнойника. См. *Абсцесс аппендикулярный*.

АППЕНДИЦИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (APPENDICITIS CHRONICA). Симптомы и течение. При рецидивирующем аппендиците в анамнезе характерные приступы. При первичном хроническом аппендиците неопределенные боли в правой подвздошной области, тошнота, запоры, диспепсия, болезненность в правой подвздошной области.

Лечение. Лучший метод — операция в холодном периоде. До операции — растительно-молочная диета с ограничением черного хлеба, капусты, картофеля и мяса. Одновременно применяют

салол с белладонной и местно грелку, а при запорах — клизмы, лучше масляные (подсолнечное масло 150—200 г).

АСФИКСИЯ см. *Наркоз*.

АСЦИТ см. *Водянка живота*.

АТЕРОМА (ATHEROMA). Истинная ретенционная киста сальной железы кожи. Развивается главным образом на голове, лице и спине.

Симптомы и течение. Атеромы бывают одиночные и множественные. Имеют округлую форму и величину от горошины до размеров куриного яйца, а иногда и больше. Увеличиваются в объеме медленно. После травм и проникновения в них инфекции атеромы воспаляются и нагнаиваются, становясь болезненными.

Лечение. Удаление опухоли вместе с оболочкой. Следует оперировать, не дожидаясь нагноения.

БУРСИТ ОСТРЫЙ (BURSITIS ACUTA). ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ СУМКИ. Симптомы и течение. Общие лихорадочные явления: повышенная температура (37—38°), общая разбитость, потеря аппетита и т. д. Нередко общая реакция протекает бурно с температурой до 39—40°. Местные явления зависят от локализации пораженной сумки. Отмечаются боли, расстройства функций, при более поверхностном процессе — воспалительная окраска и отечность кожи. Первоначально процесс носит ограниченный характер. Скопление выпота дает характерную для данной сумки форму. Быстро появляется отек окружающей области. Процесс переходит за пределы сумки и идет по типу распространенной флегмоны, давая поверхностные и глубокие затеки. Наличие гноя в замкнутой полости сумки под большим давлением часто вызывает лимфангоит и лимфаденит. Возможен переход гнойного процесса на соседний сустав.

Лечение. Выжидательное лечение (пенициллино- и сульфаниламидотерапия, согревающие компрессы, покой) допускается лишь в первые дни заболевания. Основным методом лечения — ранние разрезы (ввиду незначительного размера сумки и ее глубины, получить флюктуацию часто не удается).

БУРСИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (BURSITIS CHRONICA). ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ СУМКИ. При гонорройной инфекции, маловирулентной инфекции и хронических раздражениях сумки (травмы) развивается хронический серозный, нередко обостряющийся процесс в сумке.

Симптомы и течение. Стенки сумки утолщаются, она растягивается выпотом; выделившийся фибрин организуются в плотные свободные тела (рисовидные тела); такая сумка прощупывается иногда в виде значительного образования, напоминающего кистозную опухоль.

Лечение. Необходимо иссечение всей сумки. Разрез ее дает длительно не заживающий свищ.

ВАРИКОЗНОЕ (УЗЛОВАТОЕ) РАСШИРЕНИЕ ВЕН ГОЛЕНИ (VARICES VENARUM). Предрасполагающие причины: работа, связанная с длительным стоянием на ногах; опухоли в области таза, сдавливающие подвздошные вены и затрудняющие отток крови; слабость мышечных и эластических волокон стенки вены; недоста-

точность венозных клапанов. Расширение часто неравномерное и имеет вид узлов.

**Симптомы и течение.** Заболевание может не беспокоить больных, однако часто вызывает чувство тяжести в ногах и быструю утомляемость, а также боли и судороги в икрах. Расширенные вены видны через покровы, особенно при стоянии больного; кожа пигментирована, истончена, возможны отеки. На коже развиваются упорные экземы или изъязвления (см. *Язва голени гарикозная*), тромбофлебит, появляются венные камни (обызвестление тромба), кровотечения при разрыве истонченной стенки узла, прогрессирующие отеки конечности.

**Распознавание.** На основании осмотра больного в стоячем положении. Недостаточность клапанов определяется следующим образом: больной ложится, ногу приподнимает вверх, что вызывает спадение вен; после прижатия пальцами большой подкожной вены у места впадения в бедренную больной встает; при прекращении сдавления вены внезапно наполняются кровью, устремляющейся сверху вниз.

**Лечение и профилактика.** Перемена характера работы. При отсутствии осложнений рекомендуется постоянное бинтование с утра эластическими бинтами равномерно с небольшим сдавливанием от стопы до середины бедра; перед бинтованием конечность поднимают вверх на 3—5 минут; на ночь бинт снимают.

В более тяжелых случаях (упорные язвы, экзема, повторные кровотечения) — хирургическое лечение.

**ВАРИКОЦЕЛЕ (РАСШИРЕНИЕ ВЕН СЕМЕННОГО КАНАТИКА (VARICOCELE)).** В некоторых случаях достигает значительных размеров. Заболевание встречается в возрасте 20—35 лет.

**Симптомы.** При осмотре в стоячем положении видны расширенные переполненные кровью вены, просвечивающие иногда через кожу. При прощупывании вдоль семенного канатика ощущаются извитые расширенные вены. В лежачем положении становятся невидимыми (опорожнение вен). Яичко на больной стороне свисает больше. Изредка ощущение тяжести или болей в мошонке. При распознавании необходимо помнить о сообщающейся водянке яичка. **Лечение.** Ношение суспензория и обмывания холодной водой. Операция (иссечение вен) показана при болях.

**ВОДЯНКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (HYDROPS VESICAE TELLAE).** Развивается в результате длительно существующей закупорки пузырного протока (например, камнем). Желчь из пузыря всасывается, и остается прозрачная тягучая жидкость, растягивающая пузырь. Эта жидкость является секретом слизистых желез пузыря. При наличии инфекции может образоваться эмпиема пузыря.

**Симптомы.** В животе, в подреберье и несколько ниже реберной дуги справа прощупывается мало болезненная, гладкая, подвижная в стороны опухоль. Состояние больных удовлетворительное. В анамнезе приступы болей в правом подреберье типа печеночных коликов.

**Лечение.** Оперативное.

**ВОДЯНКА ЖИВОТА, АСЦИТ (ASCITIS).** Скопление в брюшной полости жидкости невоспалительного характера. Развивается «

в результате застоя в воротной вене, при опухолях органов брюшной полости, циррозах печени и т. п. Наблюдается также при болезнях почек и сердца.

**Симптомы.** Живот увеличен в объеме; при исследовании живота в отлогих местах — притупление (при небольших количествах жидкости тупость полулунной формы, перемещающаяся при изменении положения тела).

**Лечение.** Состояние больных облегчают проколами живота и выпуском жидкости; прокол производится по средней линии между пупком и лобком (необходимо спустить перед проколом мочу) или в боковых частях живота. Лечение основного заболевания.

**ВОДЯНКА ЯИЧКА (HYDROCELE).** Под водянкой яичка понимают скопление жидкости в полости оболочек яичка (собственной оболочки). Различают две формы водянки яичка — врожденную и приобретенную. Врожденная водянка наблюдается главным образом у детей, развивается при аномалиях зарастания влагалищного отростка брюшины и в результате недоразвития лимфатической системы. Приобретенная водянка яичка образуется в результате травмы (ушибов), инфекции яичка и придатка (туберкулез, гоноррея, сифилис и т. п.). В результате воспаления между оболочками скапливается воспалительный выпот (экссудат — прозрачная серозная жидкость желтоватого цвета с большим содержанием белка).

Приобретенная водянка яичка может достигать больших размеров. Она может вызывать неудобство при ходьбе, а также иногда вызывает затруднение мочеиспускания. Больные жалуются на продолжающееся увеличение мошонки.

**Распознавание.** Водянка яичка представляет неправильную в брюшную полость опухоль мошонки. При проходящем свете водянка яичка просвечивает. Прощупать яичко отдельно не удастся. При постукивании — тупой звук.

**Лечение.** При врожденных водянках оперировать (иссечение оболочек) не следует раньше 3-летнего возраста.

Лучшее и радикальное лечение водянки у взрослых — оперативное.

**ВОСПАЛЕНИЕ ВРГОШЖНЫ** см. *Перитонит*.

**ВЫВИХ (LUXATIO).** Под влиянием патологического процесса или травмы происходит смещение одной или нескольких костей из их нормального положения в суставе, причем суставная поверхность одной кости соскакивает с поверхности другой вследствие разрыва или растяжения сумки.

Патологические вывихи вызываются заболеванием сустава и суставных концов костей (вправление противопоказано).

Различают свежие вывихи (в первые дни после возникновения) и застарелые, при которых сумка сустава успевает сократиться, что делает вправление затруднительным, а иногда и совершенно невозможным.

**Симптомы и течение.** При травматических вывихах: боль с момента травмы остается интенсивной по крайней мере в первые часы после повреждения; больной оберегает конечность, не дает ее трогать и сам поддерживает ее (особенно при вывихе плеча); неестественное положение конечности в суставе, определенное для

каждого вывиха (так, при вывихе плеча вперед больной держит обычно согнутую в локтевом суставе руку с отведенным от туловища локтем; при вывихе в тазобедренном суставе больная нога чаще всего поворачивается носком внутрь).

**Р а с п о з н а в а н и е .** Отличительный признак — почти полная неподвижность в суставе и фиксированное положение конечности именно в таком неправильном положении. В области самого сустава при вывихе наблюдается опухоль, увеличивающаяся в последующие дни, и кровоизлияние.

**Л е ч е н и е .** По отношению к вывихам каждого отдельного сустава предложены различные способы вправления. Вправление вывиха лучше всего удается в течение первых дней после повреждения, а поэтому следует производить его возможно раньше.

Метод вправления вывиха плеча (по Джанелидзе): после инъекции морфина больного кладут на бок (пл больную сторону), рука свисает за конец стола, голову удерживает помощник; после расслабления мышц (через 15 минут) руку сгибают в локте и производят вытяжение вниз за согнутое предплечье, повертывая конечность сначала кнаружи, а затем внутрь.

После вправления — покой, массаж; через несколько дней — движения, лечебная физкультура.

**ВЫВИХ БЕДРА ВРОЖДЕННЫЙ (DYSPLASIA FEMORIS CONGENITA).** В результате недостаточного развития вертлужной впадины или головки бедра головка выходит из вертлужной впадины, образуя, таким образом, вывих. Чаще бывают односторонние, реже — двусторонние вывихи.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** У новорожденного ребенка клиническая картина не всегда ясна; вывих распознается большей частью тогда, когда ребенок начинает ходить. При одностороннем вывихе конечность укорочена; большой вертел стоит высоко и не так резко выдается; при стоянии ребенок наклоняет туловище в больную сторону; подвижность бедра нормальная, а иногда чрезмерна (в тазобедренном суставе). При двустороннем вывихе живот выпячен вперед, лордоз в поясничной части; больные при ходьбе раскачивают туловище в сторону вывиха, характерна «утиная походка». Распознаванию помогает следующий симптом: если заставить больного стоять на одной ноге, а другую согнуть в тазобедренном суставе под прямым углом, то седалищные складки остаются горизонтальными или складки согнутой ноги бывают выше; если же заставить больного стоять на больной конечности, то таз наклоняется в здоровую сторону.

**Л е ч е н и е** ортопедическое (некроавое вправление) с наложением этапных гипсовых повязок или оперативное. Цель вмешательства — поставить головку на место.

**ВЫВИХ ПРИВЫЧНЫЙ (DYSPLASIA HABITUALIS).** Привычные вывихи, происходящие в одном и том же суставе несколько раз. Вывих повторяется очень легко, иногда даже при неловком движении рукой. Страдание тяжелое, порой лишающее больного трудоспособности.

Причины: разрыв и растяжение суставной сумки, облегчающие смещение костей в суставе; надрыв мышц; атрофия их и параличи.

**С и м п т о м ы .** Легко происходящие вывихи (от незначительных причин). Обычные свойственные вывиху признаки с меньшей болезненностью и ограничением движений. Имеет значение анамнез.

**Л е ч е н и е .** В момент вывиха — вправление. Производится обычно очень легко, иногда даже самим больным. Для укрепления суставной сумки применяют консервативное лечение (ограничение движений, ванны, массаж, электротерапия), при безуспешности — операция (ушивание сумки, мышечная пластика).

**П р о ф и л а к т и к а .** Вправление вывихов без травмирования сумки, правильный режим после вправления, осторожные движения для предупреждения повторений.

**ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ (PROLAPSUS RECTI).** Чаша всего встречается в детском возрасте. Различают выпадение слизистой заднего прохода (prolapsus ani) и выпадение всех слоев прямой кишки (prolapsus recti). Причины у детей: запоры, дизентерия, натуживания при заболеваниях кишечника, фимозах и т. д., расслабление мышц и связочного аппарата прямой кишки и тазового дна, более отвесный и прямолинейный ход прямой кишки; у взрослых — запоры, геморрой, заболевания кишечника; у женщин — роды и тяжелая работа.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** При выпадении слизистой заднего прохода во время испражнения появляется выпячивание слизистой оболочки заднего прохода в виде яркокрасной розетки; по окончании испражнения выпавшая слизистая уходит обратно. При выпадении всех слоев прямой кишки выпадает часть кишки в виде цилиндра; слизистая выпавшей части кишки, вследствие постоянной травмы, набухает, подвергается воспалительным изменениям с образованием язвы и эрозий. В первое время выпавшую часть кишки больные вправляют сами (после дефекации), но в дальнейшем вправление становится трудным и даже невозможным; появляется недержание кала и газов, боли. Выпавшая часть кишки может ущемляться.

**Л е ч е н и е .** Устранение причин, вызвавших выпадение (устранение запоров, поносов и т. д.). Детям разрешают испражняться только в лежачем положении; устанавливают определенный режим питания. Выпавшую часть кишки вправляют, поставив больного в коленно-локтевое положение. Длительное выпадение прямой кишки у взрослых (у детей редко) требует в некоторых случаях операции.

**ВЫТЯЖЕНИЕ.** Имеет целью расслабление мышц, которого в большинстве случаев достаточно для установки отломков кости в правильное положение.

Вытяжение силой тяжести. Применяется при наложении неподвижной повязки, например, на позвоночник (корсет) и на область тазобедренного сустава. При вытяжении на более длительный период больного кладут на наклонную кровать с приподнятой верхней частью туловища. Это постоянное вытяжение будет тем сильнее, чем наклоннее кровать. Применяется при туберкулезе позвоночника и переломах его.

Вытяжение с помощью липкого пластыря. Берут длинную полоску пластыря шириной 5—8 см для бедра, 4—5 см для голени,

3—4 см для предплечья и ведут ее вдоль по- оси больного члена, а затем перегибают в виде свободной петли через область сустава и так же ' укладывают с другой стороны. Вставляют в петлю пластыря дощечку, к которой прикрепляют веревку. Последнюю перекидывают через систему блоков и к ней привязывают груз. Надо следить, чтобы блок был на уровне центра распорки, а веревка составляла бы одну прямую линию со средней линией пластырной полоски и скользила по середине желобка отвесно стоящего блока. На конец веревки прикрепляют груз.

Вытяжение скелетное. Наиболее энергично вытяжение металлических спицами или скобками. Спицу проводят через покровы и кость (чаще верхний конец большеберцовой кости, реже — через надмыщелки бедра и пяточную кость) в поперечном к оси конечности направлении под местным обезболиванием и к ней прикрепляют вытяжение. Скобку после стерилизации накладывают так, что ее острые концы углубляются в кость, но не проходят ее насквозь.

ГАЗОВАЯ ГАНГРЕНА. Газовую инфекцию вызывают главным образом *Bac. perfringens*, *Vibrio septicus*, *Bac. oedematiens*, *Bac. histolyticus*. Она встречается преимущественно после ранений в военных условиях, особенно при осколочных ранениях нижних конечностей, сопровождающихся значительным повреждением мышц; в мирных условиях — при уличных травмах и случайных ранениях, а также после инъекции лекарственных веществ без достаточного соблюдения асептики.

Развитию газовой инфекции могут способствовать сплошные гипсовые повязки, неосторожная эвакуация и наложение жгута и давящих повязок.

**Симптомы и течение.** Болевые ощущения в области раны, увеличение объема больного органа (отек). Температура 39—40°, пульс 120—130 ударов в минуту. Бледность кожи, иногда бронзовая окраска, отек в окружности раны, наличие газа в подкожной клетчатке (крепитация), сухость раны, серозное и геморрагическое отделяемое с пузырьками газа и изменение вида мышц в ране (вид вареного мяса).

**Лечение** хирургическое неотложное. При поверхностном распространении процесса — срочные множественные широкие разрезы (при процессе па "туловище — окаймляющие разрезы в здоровых тканях). При глубоким процессом с расстройствами кровообращения (конечность холодна, пульсации нет) и при быстром прогрессировании или резком ухудшении общего состояния — срочная ампутация выше места поражения. Дополнительное лечение — введение антигангренозной сыворотки в 3—5 раз больших дозах, чем профилактические (см. *Профилактика*). Сыворотка вводится внутривенно (процесс введения может сопровождаться шоком), внутримышечно и подкожно. Одновременно капельное введение крови, сульфамидные препараты — стрептоцид 10 0—12,0 про еlio, сульфазол 6,0 про die, а также пенициллин по 50 000—100 000 единиц каждые 3 часа.

**Профилактика.** Для предупреждения газовой инфекции необходимо возможно быстрое оказание первой помощи, состоящей из

## III

иммобилизации конечности, хирургической обработки раны без последующего шва и применение, по возможности, в первые часы после ранения пенициллина, антигангренозной сыворотки, согласно указаниям на упаковке: antiperfringens — 4 500 AE, antioedematiens — 7 E00 AE, antihistolyticus — S00 AE и antivibrio septicus — 1 500 AE.

ГАНГЛИИ (GANGLION). Кистозное образование, располагающееся на тыльной поверхности лучезапястного сустава, ладони, в редких случаях в области коленного сустава истовы. Имеет значение травма. Наблюдается нередко у пианистов, машинисток.

**Симптомы и течение.** Ганглий представляет шаровидную опухоль размером от горошины до лесного ореха (иногда и больше), подвижную и не спаивающуюся с кожей, опухоль эластична и напряжена, иногда тверда, как хрящ.

**Лечение.** Раздавливание кисты (ее разрыв) большим пальцем или ударом (руку укладывают на мягкое, на опухоль накладывают полотенце — и ударяют деревянным молотком). Лучшей надежнее оперативное удаление ганглиев.

ГАНГРЕНА (GANGRAENA). Нейротрофические, механические, химические и физические факторы, а чаще всего расстройство кровообращения вызывают омертвление тканей.

Гангрена влажная. **Симптомы и течение.** Инфекционный гнилостный распад тканей грязнозеленого цвета. Боли. Прогрессирование и распространение гангрены на здоровые ткани. Общая интоксикация, повышенная температура.

**Лечение.** В начальных стадиях — спиртовые и антисептические высушивающие повязки. При прогрессировании процесса — безотлагательная ампутация в пределах здоровых тканей.

Гангрена газовая см. *Газовая гангрена*.

Гангрені самопроизвольная (gangraena spontanea), облитерирующая тромбангрит, тромбангит. Начинается со спазма сосудов конечностей, утолщения их внутренней стенки, что вызывает сужение просвета, тромбоз сосудов и нарушение кровообращения, ведущие к гангрене конечности.

**Этиология.** Не совсем ясна. Первичной причиной, повидимому, является поражение нервной системы; имеют значение нарушения функции желез внутренней секреции (надпочечников) и хронические интоксикации (никотин, алкоголь).

**Симптомы.** Переменяющаяся хромота (боли при ходьбе, прекращающиеся при остановке); боли в конечности в покое и ночное похолодание пальцев; побледнение или синюшность пальцев; отсутствие пульсации в периферических артериях (a. dorsalis pedis). Вначале небольшой, затем прогрессирующий участок омертвления, начинающийся с пальцев.

**Лечение.** В начальных стадиях — физиотерапевтическое лечение (диатермия, грязелечение, лечение озокеритом, ванны). Повторные вливания гипертонического раствора поваренной соли по 100—250 мл в вену. Внутривенное введение 100 мл дистиллированной воды. Введение в околопочечную клетчатку 0,25% раствора новокаина — 50—100 мл (по Вишневскому), внутримышечное введение 3% раствора витамина B<sub>12</sub> два раза в сутки

по 2,0. Местно — антисептические влажные высыхающие, спиртовые повязки и повязки с мазью Вишневского. Применяются также различные способы оперативного лечения вплоть до ампутации.

Rp. Sol. Natrii chlorati 10% 500,0 Sterilisetur! S. Для  
внутривенного введения по 100,0—200,0 мл  
Rp. 01. Cadinis. s. Picis liquidae 3,0—5,0 T-gae  
Iodi (10%) 1,0 01. Ricini 100,0 ■ M. f. ung.  
DS. Мазь Вишневского

Гангрена сухая. С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Сухое омертвление или мумификация чаще встречается на периферической части конечности. Демаркация происходит на границе здоровой части. Боли.

Л е ч е н и е. До образования демаркации для предохранения от инфекции — спиртовые повязки. Блокада поясничная по Вишневскому 0,25% новокаином — 50,0. Ампутация в пределах здоровой ткани.

ГЕМАРТРОЗ. Кровоизлияние в сустав. Наступает после повреждения суставных поверхностей или связок, а также при кровоточивости. Кровь смешана с синовиальной жидкостью и обычно свертывается.

С и м п т о м ы. Резкие боли при движениях и в покое, ограничение и болезненность движений, принужденное положение некоторого сгибания в суставе. Опухоль в области сустава повторяет контуры суставных заворотов, определяется выпот в суставе.

Рассасывание длительное; возможны ограничения подвижности.

Л е ч е н и е. Давящие повязки на область сустава, пузырь со льдом, шинные повязки, с 3—4-го дня для ускорения рассасывания применяются грелки. Осторожные движения с 10—12-го\* дня.

В хирургических учреждениях применяется пункция, отсасывание крови, ускоряющее выздоровление.

ГЕМАТОМА (НАЕМ-АТОМА). КЮВЯНАЯ ОПУХОЛЬ. Травма сосуда при ушибе или разрыв его стенки дает кровоизлияние в ткани и скопление крови в них. При отсутствии инфекции гематома обычно подвергается рассасыванию, но может вызывать появление кисты с кровянистым содержимым (травматическая киста). При инфицировании гематомы развивается нагноение.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Большая припухлость в области травмы, дающая зыбленье; при более поверхностной локализации ее — видимое кровоизлияние в подкожной клетчатке (синяк). Обратное развитие медленное. При нагноении — повышение температуры, усиление болей, появление красноты и сформирование гнойника. Исход — рассасывание или образование абсцесса.

Л е ч е н и е. Сразу после травмы — холод (уменьшает кровоизлияние), со вторых суток после травмы — грелки и компрессы для рассасывания опухоли. При нагноении — операция.

ГЕМАТУРИЯ (НАЕМАТУРИА). Выделение крови с мочой либо в виде примеси, заметной на глаз, либо определяемой только при микроскопическом исследовании мочевого осадка. Может наблюдаться при острозаразных и других болезнях (например, нефрите, цистите, болезни Верльгофа, лейкемии, кровоточивости, туберкулезе и опухолях почек). Наиболее ярко гематурия проявляется при повреждениях почек и мочевыводящих путей, а также при камнях почек и мочевого пузыря. Выделение длинных сгустков крови может указывать на процесс в почках и мочеточниках.

Л е ч е н и е. Лечение основного заболевания (консервативное и оперативное). Симптоматически — лед на область почек и мочевого пузыря, покой.

ГЕМОРОИ (VARICES HAEMORRHOIDALES). Причины: слабость сосудистой стенки и застой крови вследствие неблагоприятных условий оттока из вен нижнего отрезка прямой кишки (сидячий образ жизни, запоры). Наблюдается у лиц, профессия которых требует напряжения брюшного пресса, ведущего к застою в системе нижней полой вены и к расширению вен нижних конечностей, семен.-ного канатика и вен нижнего отрезка прямой кишки; у женщин — при беременности, опухолях и загибах матки. Различают наружный геморрой, когда узлы располагаются под кожей в области сфинктера (запирательной мышцы), и внутренний — в начальной части прямой кишки.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Жалобы на чувство зуда, жжения, жара, боли в заднем проходе. Вследствие разрыва расширенных капилляров слизистой, наблюдается кровотечение при испражнении. При осмотре заднего прохода видны набухшие и расширенные вены в виде отдельных узлов. Слизистая оболочка нижнего отдела прямой кишки, покрывающая узлы, воспалена вследствие нарушения питания и траматизации вен проходящим калом. При закупорке сосудов узлы становятся твердыми, а при воспалении — болезненными; при этом повышается температура, появляется отек-вокруг заднего прохода. При занесении инфекции могут образоваться гнойники; узлы могут ущемляться, давая сильные боли.

Л е ч е н и е. Изменение образа жизни, перемена профессии, устранение запоров. Прохладные ежедневные обмывания заднего прохода, легкая диета. Укрепление и закаливание организма (спорт улучшает отток крови). Против болей — свечи с белладонной. При отсутствии улучшения — перевязка узлов. Перед операцией больным очищают кишечник (15,0—30,0 мл касторового масла, клизма из 10% раствора поваренной соли — 75—100 мл). После операции назначается жидкая пища, опий по 8—10 капель в течение 5—6 дней. При задержке мочеиспускания в первые дни после операции нужно придать больному полусидячее, сидячее или боковое положение, а на область пузыря — тепло (грелка).

ГИГРОМА, или бураит (HYGROMA). Причина бурсита травма, вызвавшая кровоизлияние в слизистую сумку, а более часто — повторная механическая травма при давлении на сумку. Часты локализации в области передней поверхности надколенника, области локтя, под дельтовидной мышцей, в области большого вертела бедра, в подколенной области, под ахилловым сухожилием.

В сумке появляется серозный выпот, утолщение сумки, ворсинчатые разрастания, свободные фибриновые тельца, отложение извести (bursitis calcarea).

**Симптомы.** Эластичная, округлая опухоль в типичном месте, безболезненная или мало болезненная, иногда дающая сильные боли при движениях (bursitis calcarea). Основание опухоли плотно связано с глубжележащими тканями, кожа подвижна. Возможны улучшения (исчезновение опухоли) и обострения.

**Лечение.** Согревающие компрессы, защита от повторных травм. Пункции показаны при остром течении, в прочих случаях — иссечение сумки. При bursitis calcarea — рентгенотерапия.

**ГИДРАДЕНИТ ПОДМЫШЕЧНЫЙ (HYDRADENITIS SUBMAMILLARIS). ВОСПАЛЕНИЕ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ.** Возбудитель — стафилококки, стрептококки. Развитию воспаления способствуют потливость и расчесы.

**Симптомы и течение.** Появление в подмышечной области поверхностных инфильтратов, плотных наощупь, затем размягчающихся и дающих в центре зыбление. При прорыве скопления гноя заболевание может ликвидироваться или перейти на соседние потовые железы и вызвать множественные воспалительные очаги.

**Лечение.** При образовании инфильтрата хорошие результаты дает пенициллинотерапия, лечение кварцевой лампой (эритемные дозы), предохраняющее от появления новых очагов, лечение ионизирующим излучением, вводимым под инфильтрат. Избегать согревающих компрессов. При формировании отдельных абсцессов и появлении размягчения в центре инфильтрата необходима операция. Для защиты окружающей гнойник кожи от раздражения и для предупреждения появления новых гнойников — мази (смазывание) или повязки с эмульсией стрептоцида (emulsionis streptocidi).

Rp. Ung. praecipitati albi 30,0  
Ac. carbolicis crystallisati 0,3  
M. f. ung.  
S. Наружное

**ГИДРОНЕФРОЗ (HYDRONEPHROSIS). ВОДЯНКА ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК.** Врожденные или приобретенные препятствия к выделению мочи могут вызвать растяжение лоханки, а затем и их чашечек. Почечная паренхима атрофируется и растягивается, и почка превращается в мешок, наполненный 3—5—15 л мочи.

**Симптомы и течение.** Начальные формы проходят незаметно для больных. В дальнейшем появляется чувство тяжести в пояснице или в подреберье, особенно при ходьбе и работе. Иногда отмечаются обострения характера почечных колик с учащением мочеиспускания, уменьшением количества мочи, тошнотой, рвотой; после приступа болей выделяется значительное количество мочи по ночам.

При ощупывании в подреберье эластическая объемистая опухоль, дающая зыбление.

**Лечение.** В период обострения лежащее положение и наркотика. В спокойный период больные подлежат специальному обследованию для выяснения необходимости и целесообразности оперативного лечения. При инфицированном гидронефрозе (высокая

температура, большое количество лейкоцитов в моче) больные подлежат срочной операции.

**ГЛОССИГ** см. *Языка острое гнойное воспаление.*

**ГНОЙНИК** см. *Абсцесс.*

**ГИПЕРТРОФИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ** см. *Предстательной железы гипертрофия.*

**ГРЫЖИ.** Грыжа бедренная (hernia femoralis). Мешок грыжи с содержимым выходит через бедренный канал кнутри от бедренных сосудов. Встречается преимущественно у женщин; часто бывает певиривимой, легко ущемляется.

**Симптомы и течение.** Опухоль лежит ниже пауперной связки, спускается на бедро. Ущемленную и невправимую бедренную грыжу надо отличать от воспаления паховых лимфатических узлов.

**Лечение.** Оперативное.

Грыжа белой линии (hernia lineae albae). Нередко встречается у лиц физического труда — грузчиков. Встречается и у детей, как следствие недоразвития. Вначале через щель в апоневрозе выходит предбрюшинная жировая клетчатка, затем воронка брюшины, и, наконец, образуется грыжевой мешок, в который чаще всего выпадает сальник; ущемление встречается редко.

**Симптомы и течение.** Округлая опухоль, плотной консистенции по средней линии живота, иногда исчезающая при надавливании. При диспептических явлениях необходимо исследование желудочно-кишечного тракта.

**Лечение.** Хирургическое.

Грыжа брюшная (hernia abdominalis). Предрасполагает к развитию грыжи наследственная слабость брюшной стенки, исчезновение жировой клетчатки при похудании, перерождение мышц при ожирении, ослабление брюшной стенки после ее повреждения. Основная причина — повышение внутрибрюшного давления при запорах и затруднениях мочеиспускания, подъеме больших тяжестей, кашле и крике у маленького ребенка.

Через ослабленный участок брюшной стенки, где образуется отверстие или щель (грыжевые ворота), выпячивается брюшина (грыжевой мешок). Содержимое мешка — кишечные петли, сальник и другие подвижные органы брюшной полости.

**Симптомы и течение.** Наличие опухоли брюшной стенки, вправляющейся при лежании и надавливании и увеличивающейся при натуживании и кашлем толчке. Боли при работе и ходьбе.

**Лечение.** Оперативное.

Грыжа паховая (hernia inguinalis). Чаще встречается у мужчин. Различают врожденные и приобретенные грыжи. При незаращении влагалищного отростка брюшины грыжа выходит через паховый канал (вместе с канатиком у мужчин и круглой связкой у женщин). Грыжа, выходящая через внутреннее отверстие пахового канала, идет в косом направлении (косая грыжа) и спускается быстро в мошонку (пахово-мошоночная грыжа), а при выхождении кнутри от внутреннего отверстия, пахового канала (прямая грыжа) она имеет вид половинки апельсина и долго не спускается в мошонку.



**Симптомы и течение.** Опухоль в паховой области. Палец, введенный в паховый канал, ощущает при натуживании выпячивающийся грыжевой мешок; при покашливании ощущается толчок. Паховые грыжи у мужчин можно смешать с водянкой яичка и воспалением придатка яичка.

**Лечение.** Оперативное.

Грыжа послеоперационная (*hernia postoperationem*) и грыжа травматическая (*hernia traumaticae*). Послеоперационная грыжа образуется при расхождении внутренних швов брюшной стенки и после заживления брюшной раны вторичным натяжением, после введения в брюшную полость тампонов и дренажей.

**Симптомы и течение.** Выпячивание в области рубца после операции или ранения брюшной стенки на всем его протяжении или на отдельном участке его, исчезающее при лежании и надавливании.

**Лечение.** Оперативное.

Грыжа пупочная (*hernia umbilicalis*) встречается у взрослых (преимущественно у женщин) и у детей. Выходит через пупочное кольцо. Грыжа взрослых часто невправима; при значительном увеличении может наступить изъязвление рубца над грыжей. Часто ущемляется. Пупочная грыжа у детей ущемляется крайне редко.

**Симптомы и течение.** Опухоль обычно небольшого размера. Нередко мешок имеет множественные полости. При покашливании грыжа увеличивается.

**Лечение.** Грыжи взрослых подлежат операции. Детские грыжи лечатся консервативно при помощи полосок липкого пластыря, накладываемых крестообразно на область пупка после вправления грыжи. Операция производится не ранее трехлетнего возраста.

Грыжа ущемленная (*hernia incarcerata*). Ущемлению грыжи способствуют: узость грыжевых ворот, неподатливость и плотность их краев, воспалительные изменения в области грыжевого мешка, повышение внутрибрюшного давления при натуживании, сокращение мышц, окружающих грыжевое отверстие, и вздутие кишечника. Через несколько часов после ущемления кишечной петли нарушается ее кровообращение, через стенку происходит пропотевание жидкости в просвет кишки и грыжевой мешок (грыжевая вода); бактерии из просвета кишки проникают в грыжевой мешок, и кишечная петля омертвевает.

**Симптомы и течение.** Грыжа перестает вправляться, появляются боли в области грыжи или в брюшной полости; грыжа становится напряженной, резко болезненной при ощупывании. Задержка стула и газов, вздутие живота, рвота. Проникающая из кишечной петли инфекция вызывает перитонит, реже каловую флегмону грыжевого мешка.

**Распознавание.** Если грыжа раньше не была диагностирована, то на ущемление грыжи указывает внезапное появление опухоли в типичном для грыжи месте (паховая, бедренная, пупочная и другие области), появление болей, задержка стула и рвота.

**Лечение.** Немедленная операция. До доставления в больницу — возвышенное положение таза с пузырем льда на область

грыжи или теплая ванна и введение атропина под кожу. Ручное вправление, ввиду его опасности, применять не следует.

Rp. Sol. Atropini sulfurici 1 : 1 000 5,0  
Sterilisetur! DS. По 1 мл под кожу

**ДЕФОРМАЦИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ.** *Coxa vara* — изгиб шейки бедра, при котором тупой угол шейки бедра уменьшается и превращается в прямой. Развивается в результате рахита и ненормальной нагрузки в период роста; в результате перенесенных заболеваний головки и шейки бедра (остеомиелита, туберкулеза, деформирующего артрита, травм). При рахите эта деформация двусторонняя.

**Симптомы и течение.** При осмотре выявляется высокое стояние больших вертелов и выстояние их. При ходьбе больной переваливается, походка неуклюжая. Отведение бедра ограничено. Сгибание в тазобедренном суставе свободно. Повертывание кнаружи нормально или слегка затруднено. При искривлении с одной стороны после переломов шейки бедра, туберкулеза, остеомиелита наблюдается укорочение ноги.

*Genu valgum* (искривление колен внутрь — Х-образные ноги).

**Симптомы и течение.** Бедро и голень образуют угол, открытый кнаружи; при сгибании в коленном суставе деформация исчезает. Причина — задержка в росте наружных и разрастание внутренних мыщелков, искривление бедра и голени, повреждение росткового хряща в области наружного мыщелка и неправильно сросшиеся переломы бедра и голени.

*Genu varum* (искривление колен наружу — О-образные ноги). Встречается у больных рахитом в результате задержки роста внутренних мыщелков. Образуется угол, открытый кнутри.

**Лечение.** У детей — этапное насильственное исправление формы ноги. У взрослых — надмыщелковая остеотомия (иссечение части кости). То и другое производится в больнице.

**ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ.** Неправильность в развитии кишечника. На тонкой кишке на расстоянии 1,5 м от баугиновой заслонки образуется выпячивание кишечной стенки в виде отростка различной длины, переходящего иногда в тяж.

**Симптомы.** Дивертикул Меккеля открывается свищом в области пупка. Кишечная непроходимость развивается вследствие перетяжки кишечной петли или воспаления дивертикула, напоминающего по картине болезни аппендицит.

**Лечение.** Удаление оперативным путем.

**ДИВЕРТИКУЛ ПИЩЕВОДА (DIVERTICULUM OESOPHAGY).** Различают выпячивание стенки пищевода от действия тяги извне при воспалительном процессе, чаще при туберкулезе лимфатических желез (тракционные), и при повышении давления внутри пищевода при слабости мышечной стенки в каком-либо ее участке (пульсиоп-вне), а также комбинированные. По месту расположения (глоточно-пищеводные на 20 см от края резцов) — на высоте бифуркации

трахеи (IV—V грудной позвонок) и в нижней трети пищевода. Слизистая утолщена, нередко изъязвлена.

**Симптомы.** Небольшие дивертикулы могут симптомов не давать; при больших — развивается расстройство глотания (дисфагия), слюнотечение, позывы на рвоту, срыгивание, ощущение давления в области шеи, тухлый запах при кашле, затруднения дыхания, боли в груди, исхудание. Возможны перфорации. Распознается преимущественно при рентгеноскопии.

**Лечение.** Хорошо размельченная пища, запиваемая какой-нибудь жидкостью. Хирургическое вмешательство.

**ДИЕТА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ.** Питье. Во время операции (потеря крови) и вскоре после нее (потение после эфирного наркоза, рвота) организм больного теряет значительное количество жидкости. Обезвоживание организма сказывается в мучительной жажде. После операции под местной анестезией жажду можно удовлетворить питьем простой или минеральной воды, теплого или холодного чая с лимоном, клюквенного морса и т. д., если при операции не затронут желудок и кишечник. Если больной не пьет, то недостающее количество жидкости (1 000—1 200 мл в сутки) должно быть введено путем солевых (по 100 мл физиологического раствора каждые 2—3 часа) или капельных клизм (100 мл 1—2 раза в день), если операция была не на нижнем отрезке кишечника. Нередко вводят физиологический раствор под кожу или в вену по 500—600 мл 2 раза в сутки. Полоскание рта водой или обтирание губ и языка влажной ватой. После наркоза при отсутствии позывов на рвоту можно давать пить глотками каждые 15 минут (за исключением больных с операциями на желудке, пищеводе и полости рта).

**Питание.** После операции должно быть строго индивидуализировано, в зависимости от способа обезболивания и характера операции. После операции под местной и спинномозговой анестезией питание может быть начато, если это позволяет произведенное вмешательство, уже в день операции. После операции, не затрагивающей брюшной полости, может быть назначена легкая диета: бульон, протертая каша, кисель, сухари, на 2—3-й день больного переводят на обычное питание. Стол № 2 по Певзнеру. После лапаротомии — ограниченное питание: бульон, суп с сухарями, кисели, печеные яблоки, жидкая каша, яйцо всмятку. Стол № 1. После операции на желудок и кишках — специальная диета. Стол № 1 а. В течение первых 5 дней дают только жидкую пищу (бульон, разболтанное с водой сырое яйцо, жидкий кисель); на 6-й день разрешают кашицеобразную пищу (яйцо всмятку, манную кашу, пюре из овощей). Стол № 16. С 8-го дня постепенно переходят к обычной диете. После операции на желудке по поводу язвы питание не должно возбуждать рвоту и раздражать пищеварительные железы; стол № 0 и затем № 16, противопоказаны бульон, мясо, острые блюда; следует давать молоко, белки, масло. После операции на толстых кишках — кушанья, которые почти целиком всасываются, не давая каловых остатков. Стол IV» 0. За 1—2 дня до операции — чай, молоко, кофе, бульон, кисель, жидкая каша, сухари; за 2 дня до операции — слабительное (касторка); накануне операции — клизма и настойка опия (по 7—10 капель 3 раза в сутки) до 6-го дня. После операции; после операции до 6-го дня —

пища жидкая, кашицеобразная (пюре, кисель, желе); стол № 0 на 4—5-й день — слабительное, легкая диета; стол № 4 — легкое слабительное дают в дальнейшем ежедневно.

**ЗАВОРОТ КИШОК (VOLVULUS INTESTINARUM)** (см. *Непроходимость кишечника*). Образуется при повороте вокруг своей оси участка кишечника вместе с брыжейкой. Предрасполагающие моменты: длинная брыжейка, рубцы в корне брыжейки, обильное введение грубой пищи в пустой кишечник.

**Симптомы и течение.** Внезапные сильные боли в животе, рвота, вздутие живота, отсутствие стула и отхождения газов. Быстро развивается тяжелое состояние: осунувшиеся черты лица, частый малый пульс, цианоз, похолодание конечностей, рвота с каловым запахом. При отсутствии быстрой хирургической помощи больные погибают от интоксикации или перитонита.

**Лечение.** Не применять слабительных и наркотиков; разрешается сифонная клизма. Быстро доставить в больницу для операции.

**ЗАДЕРЖКА МОЧИ** см. *Мочеиспускания расстройств*.

**ЗАДЕРЖАНИЕ ЯИЧКА (RETENTIO TESTICULI).** До 6—7-го месяца внутриутробной жизни яичко находится в животе плода у нижнего полюса почки. Постепенно оно опускается с ростом плода в мошонку, проходя через паховый канал. Опускание яичка в некоторых случаях останавливается, и яичко может задержаться в животе, в паховом канале или у наружного его отверстия.

**Симптомы.** Боли при ходьбе, подъеме тяжестей, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, что иногда служит к ошибочной постановке диагноза ущемленной грыжи. Задержание и эктопия яичка бывают односторонними (монорхизм) и двусторонними.

**Лечение.** Задержавшееся в паховом канале или у его наружного конца яичко может быть низведено в мошонку с помощью операции. В детском возрасте прибегать к операции не следует раньше 10—12-летнего возраста (к этому времени надежды на самопроизвольное запоздалое спускание нет).

**ЗАКУПОРКА ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА.** Сдавления протока вызывают опухоли поджелудочной железы или общего желчного протока, закупорка его камнем, аскаридой, а также рубцовое стягивание, воспалительное набухание, давление инфильтрата. Застой желчи дает расширение ходов, увеличение печени, дегенерацию ее клеток и цирроз. Функции печени резко нарушены.

**Симптомы.** Жалобы на слабость, кожный зуд; интенсивная желтуха, замедление пульса, обесцвеченный стул. В крови реакция на билирубин прямая, количество его более 0,5 мг%. В моче желчные пигменты.

**Лечение.** В тяжелых случаях оперативное лечение, в более легких — стационарное, консервативное.

**ЗАУШНИЦА** см. *Паротит*.

**ИНВАГИНАЦИЯ (INVAGINATIO INTESTINORUM).** ВНЕДРЕНИЕ КИШОК. Инвагинация — одна из форм острой непроходимости кишечника. Образуется вследствие внедрения чаще вышележащей кишки в нижележащую. Наиболее частые случаи (90%) внедрение тонкой кишки в толстую, реже — толстой в толстую и тонкой в тон-

кую. Причины инвагинации: нарушение перистальтики с длительным спазмом на ограниченном участке круговой мускулатуры кишки, колит, внутрикишечная опухоль. Инвагинация встречается чаще в раннем детском возрасте (до 1 года и реже до 3 лет); начинается она внезапно, среди полного здоровья ребенка периодически наступающими схваткообразными болями; в промежутках больной чувствует себя удовлетворительно. Иногда боли сопровождаются рвотой. В испражнениях появляется слизь и кровь. При исследовании живота иногда можно прощупать гладкую колбасовидную мягкую или эластичную опухоль в правой половине живота. Исследование прямой кишки; на пальце остается кровь и слизь; иногда прощупывается опухоль; сфинктер расслаблен. Следует отличать от острого аппендицита и дизентерии.

У взрослых инвагинация наблюдается значительно реже; протекает как закупорка кишечника с явлениями относительной непроходимости; тянется в некоторых случаях неделями, а иногда и месяцами, сопровождаясь запорами и схваткообразными болями при длительных светлых промежутках. Может прощупываться опухоль в правом подреберье или правой подвздошной области. Помогает распознаванию исследование рентгеновыми лучами с наполнением кишок контрастной массой через задний проход.

**Лечение.** Оперативное. В запущенных случаях (2—3 дня) может потребоваться резекция кишок (тяжелая для детей операция).

**ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА.** Инородные тела дыхательных путей. Семена подсолнечника, орехи, горошины и другие мелкие тела, взятые в рот ребенком, могут попасть в дыхательные пути при кашле, крике и при глубоком вдохе.

У взрослых в дыхательные пути также иногда попадают мелкие предметы, взятые в рот (мелкие гвозди у обойщиков и сапожников, булавки у портных, зубные протезы во время наркоза и т. д.).

**Симптомы.** Диагноз попадания инородного тела у взрослого ставится обычно легко на основании анамнеза, так как после попадания инородного тела наступает приступ удушья и кашля. Труднее диагноз у детей, у которых момент попадания инородного тела может быть пропущен.

Внезапный среди полного здоровья приступ судорожного кашля, стенозирующее дыхание и цианоз у ребенка, особенно если он играл мелкими предметами, подозрительны на попадание в дыхательные пути инородного тела. Неудачное инородное тело может дать ряд осложнений (пневмонии, абсцессы).

**Лечение.** При подозрении на попадание инородного тела в дыхательные пути больной должен быть направлен на специальное обследование (рентгеноскопия, бронхография) и лечение (удаление инородного тела с помощью бронхоскопии).

Инородные тела мягких тканей. Пули, осколки снарядов могут находиться в любом участке тела. Наиболее часты в мирное время инородные тела кистей рук (занозы, иглы) и подошвенной поверхности стоп (стекла, занозы). Инородные тела обычно инфицированы, часто вызывают воспалительный процесс в окружающих тканях, иногда инкапсулируются. Смещаться в тканях даже острые инородные тела (иглы) могут лишь на небольшие расстояния.

**Симптомы.** При наличии инфекции иногда формируется свищ, идущий к инородному телу, часты вспышки воспалительного процесса с вскрытием раны и отхождением гноя. Иногда определяется уплотнение или болезненность при надавливании на область рубца после повреждения. Нередко больной не подозревает о наличии инородного тела в тканях (игла, стекло).

Инородные тела определяются ощупыванием, зондированием свища, рентгенологическим исследованием (металлические инородные тела).

**Лечение.** Инородные тела, легко доступные удалению, извлекаются при перевязке или при первичной обработке раны.

Глубоко расположенные инородные тела отыскивать в рае при перевязках не следует, они подлежат оперативному удалению. При наличии свища инородные тела, безусловно, подлежат удалению.

Глубоко расположенные инородные тела, инкапсулированные и не дающие симптомов, могут не удаляться.

Инородные тела мочевого пузыря. Инородные тела попадают в мочевой пузырь через уретру при онанизме (карандаши, термометры, гвозди, головные женские шпильки и др.), при лечебных мероприятиях (катетеры, бужи), при производстве аборта, а также при огнестрельных ранениях. Вокруг попавших в пузырь инородных тел откладываются соли.

**Симптомы** (см. *Камни пузыря*). Острые инородные тела могут поранить стенку мочевого пузыря и вызвать флегмону околопузырной клетчатки. Распознаванию инородных тел в мочевом пузыре помогают цистоскопия и исследования рентгеновыми лучами.

**Лечение.** Удаление инородных тел путем оперативного вмешательства или при помощи операционного цистоскопа.

Инородные тела пищевода. Чаще всего попадают и застревают в пищеводе острые инородные тела (рыбьи и мясные кости), объемистые инородные тела (зубные протезы), а у детей монеты, мелкие части игрушек и т. д.

**Симптомы.** Загрудинные боли и боли в спине, затруднения и болезненность при глотании, слюнотечение, при объемистых инородных телах — затруднение дыхания. Ощущение инородного тела в пищеводе настолько характерно, что больной нередко сам правильно ставит диагноз. При наличии царапины в пищеводе остается ощущение инородного тела, если оно уже и прошло в желудок.

Уточняется диагноз рентгеноскопией и эзофагоскопией.

**Осложнения** см. *Прободение пищевода и медиастинит*.

**Лечение.** Все попытки удаления инородного тела вслепую или проталкивания его зондом недопустимы. Инородное тело удаляется с помощью эзофагоскопии.

Инородные тела прямой кишки. Объемистые и острые инородные тела кишечника могут остановиться у сфинктера, чаще инородными телами прямой кишки являются наконечники от клизм или осколки сломавшегося стеклянного наконечника, иногда скопление каловых масс.

**Симптомы.** Боли в области прямой кишки при дефекации, тспезм, отхождение слизи и крови, при повреждении стенки пара-

проктит и даже перитонит. Распознавание облегчает анамнез, обследование пальцем или с помощью зеркала.

**Лечение.** Некрупные и неострые инородные тела легко отходят после клизмы. Острые тела должны извлекаться хирургом. Скопления каловых масс раздробляются и извлекаются пальцем или размягчаются с помощью клизм.

**КАМЕИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (CALCULUS VESICAE URINARIAE).** В некоторых местностях камни мочевого пузыря встречаются очень часто, что объясняют особенностями питьевой воды. Иногда камни образуются при застое мочи в пузыре (остаточная моча), при попадании инфекции и инородных тел в пузырь. Камни могут образоваться в самом пузыре или опуститься в пузырь из лоханок. По химическому составу камней различают оксалаты, ураты и фосфаты.

**Симптомы и течение.** Прерывание струи мочи и задержка мочеиспускания. В некоторых случаях — дневное учащение позывов к мочеиспусканию, боли к концу акта мочеиспускания, отдающие в головку мужского полового члена, кровь в моче. Необходимы цистоскопия и рентгенография. В других случаях больные могут продолжать мочиться, только переменяв положение тела, например, поворачиваясь на бок. При присоединении инфекции развивается цистит.

**Лечение** оперативное.

**КАРБУНКУЛ (CARBUNCULUS).** Вызывается гноеродными микробами — стафилококками и стрептококками. Воспалительный процесс захватывает волосные мешочки, сальные железы и подкожную клетчатку. При дальнейшем развитии болезни в месте припухлости развиваются множественные участки некроза и нередко значительное омертвление кожи. Карбункул развивается чаще там, где происходит трение одежды о тело (поясница, область шеи и затылка), а также на лице (губы и щеки), снипе, ягодицах, реже на животе и конечностях.

**Симптомы и течение.** Значительная отечность в окружности, плотный болезненный инфильтрат багрово-красного цвета, иногда с цианотичным оттенком и со множеством бело-желтых точек, испещряющих кожу в центре заболевания. Сильные боли, высокая температура, общие лихорадочные явления. Осложнения: лимфангоиты, лимфадениты, тромбофлебиты и иногда общая гнойная инфекция (сепсис).

**Распознавание** особых затруднений не представляет. Карбункул может быть смешан только с сибирской язвой, для которой характерен резко выраженный отек на значительном протяжении в окружности, более высокая температура, наличие отслоения эпидермиса гноем в виде пузырька, затем подсыхающего в виде черной корочки.

**Лечение.** Сульфаниламидные препараты (сульфидин, сульфатиазол по 1,0 четыре раза в сутки). Пенициллин по 30 000 единиц через 3 часа. Из местных воздействий применяют физиотерапевтическое лечение (УВЧ, кварц); в окружность карбункула и под него вводят или раствор пенициллина на новокаине, или 100—150 мл 0,25% раствора новокаина (блокада по Вишневскому).

Для ускорения отторжения мертвых тканей засыпают их порошком салициловой кислоты. При прогрессирующем процессе, размягчении инфильтрата и недостаточном отхождении гноя применяют оперативное лечение.

Операция (чаще под наркозом, иногда под местной анестезией) состоит из разреза в виде креста. Разрез должен быть достаточно глубок (до апоневроза), а кожные лоскуты — приподняты и отслоены от окружающих тканей. При омертвлении значительного участка кожи образуется большая гранулирующая поверхность, долго заживающая и дающая большие рубцы.

**СОХА VARA см» Деформации тазобедренного и коленного суставов,**

**КОНСКАЯ СТОПА (PES EQUINA).** Под конской стопой подразумевают порочное положение стопы в подошвенном сгибании. Развивается конская стопа при параличах разгибателей стопы и разгибателей пальцев или же при спастическом сокращении сгибателей стопы и пальцев. У детей конская стопа образуется после перенесенного полиомиелита, а также при болезнях головного мозга (болезнь Литтля). Конская стопа может образоваться от неправильного положения стопы, при лечении гипсовой повязкой, вытяжением, длительном хождении на костылях.

**Симптомы.** При конской стопе больной наступает на кончики пальцев и даже на тыльную поверхность стопы, па которой от хождения образуется мозоль.

**Лечение.** Консервативное. Состоит из массажа, пассивных и активных движений, физиотерапии (грязелечения и парафинолечения). При застарелой конской стопе — лечение оперативное, состоящее в удлинении ахиллова сухожилия. При параличе мышц — операция мышечной пластики или артротомии.

**КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА (SCLEROSIS APONEUROSIS PALMARIS). СКЛЕРОЗ ЛАДОННОГО АПОНЕВРОЗА.** Заболевание кисти, характеризующееся первичным сморщиванием ладонного апоневроза, переходящим в дальнейшем на кожу. Болезнь начинается в среднем в пожилом возрасте. Играет роль наследственность и профессия.

**Симптомы и течение.** Под кожей ладони у IV и V пястных костей появляется уплотнение и тянется в виде жгута к пальцу. В дальнейшем основные и средние фаланги постепенно пригибаются к ладони.

**Распознавание** не трудно. Всегда следует выяснить профессиональной анамнез.

**Лечение.** В ранний период систематическое разгибание пальцев и горячие ванны могут задержать развитие болезни. Радикальным считают операцию — удаление пораженного ладонного апоневроза с последующим консервативным лечением.

**КОНТРАКТУРА (ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ) СУСТАВА (CONTRACTURA ARTHROSIS).** Развивается после воспаления или ранения сустава или мягких тканей. Может зависеть от изменения суставных поверхностей, хрящей, связок, суставной сумки, мышц (мышечная контрактура), нервов (нейрогенная контрактура) и кожи (рубцовая контрактура).

**Симптомы и течение.** Ограничение подвижности в суставе; кожные стягивающие рубцы, напряженные сведенные мышцы, повреждения нервов и другие заболевания со стороны нервной системы. Контрактура после поражения сустава остается стойкой; рубцовые и нейрогенные контрактуры могут прогрессировать.

**Лечение** зависит от характера контрактуры. Физиотерапия (ванны, парафино- и грязелечение), вытяжение, этапные гипсовые повязки, операция.

**Профилактика.** При гнойных процессах и повреждениях конечности ставят в особое положение: в тазобедренном суставе ногу слегка сгибают и отводят, коленный сустав выпрямляют, стопу ставят под прямым углом; в плечевом суставе руку отводят, в локтевом — сгибают под прямым углом, в лучезапястном — ставят в небольшом тыльном сгибании, пальцы слегка сгибают. Первый палец противопоставляют остальным.

**КОСОЛАПОСТЬ (PES EQUINO VARUS).** Чаще бывает врожденной.

**Симптомы и течение.** Стопа повернута подошвой внутрь и назад, кажется укороченной. Внутренний край стоп обращен кверху, а наружный — книзу. Подошва согнута. Пятка приподнята, мала. Ахиллово сухожилие укорочено. Вольной ходит на наружном крае стопы и даже на тыльной ее поверхности. На местах опоры при ходьбе образуется омокелость.

**Лечение.** Начинать с первых дней после рождения постепенное насильственное выпрямление. Для удержания стопы в нормальном положении накладывают повязки (мягкие, липкопластырные, гипсовые). В тяжелых и запущенных случаях выпрямление производят под наркозом или же прибегают к костнопластическим операциям.

**Наложение повязок.** После выпрямления стопы и придания ей нового положения накладывают гипсовую, липкопластырную или мягкую повязку из фланелевого или полотняного бинта; липкий пластырь накладывается на тыл стопы\*от середины или наружного края. Полоска липкого пластыря огибает внутренний край стопы и идет поперек подошвы к наружному краю, откуда косо через переднюю поверхность голени переходит на внутреннюю поверхность. Повязка из фланелевого бинта накладывается так же, как и липкоштастырная (делают те же ходы), и заканчивается спиральной повязкой на голень, предварительно обогнув бедро (согнутое в колене). Повязки продолжают делать до исправления порочного положения. Ортопедическая обувь.

**КРИВОШЕЯ (TORTICOLLIS).** В ряде случаев бывает врожденного происхождения, а также в результате травм во время родов, а результате чего образуется воспалительный процесс в мышце. Укорочение грудино-ключично-сосковой мышцы, превращение ее в плотный тяж, деформация черепа, лица, позвоночника.

**Симптомы.** Фиксированное положение головы с наклоном в сторону укороченной мышцы, поворот лица в противоположную сторону, приподнятое положение подбородка. С ростом ребенка асимметрия лица, черепа и позвоночника увеличивается.

**Лечение.** У маленьких детей во избежание прогрессирования процесса применяют массаж, вытяжение, гипсовые этапные повязки. Основной метод лечения — операция (рассечение пожек мышцы, пластическое ее удлинение, удаление всей мышцы). Оперативное лечение дает хороший результат только в раннем возрасте (от 1 года до 2 лет), пока не развилась асимметрия скелета. **КРИПТОРХИЗМ, ЗАДЕРЖКА ЯИЧЕК В ПОЛОСТИ ЖИВОТА ИЛИ В ПАХОВОМ КАНАЛЕ.** При крипторхизме обычно жалоб нет. Задержка яичка в паховом канале часто вызывает боли и иногда ущемление яичка.

**Лечение.** При задержке яичка в паховом канале показана операция (низведение яичка в мошонку). Операцию лучше делать не раньше 12 лет.

**КРОВОТЕЧЕНИЕ (HAEMORRHAGIA).** Наступает в результате нарушения целостности сосуда при травмах, распаде стенки сосуда при опухолях и гнойных процессах (вторичное кровотечение). Кровотечение может быть наружное, внутреннее (в полости тела — см. *Малокровие острое*) и в ткани (см. *Гематома*).

Артериальное кровотечение. Наиболее быстрое, значительное и опасное для жизни.

**Симптомы и течение.** Кровь выбрасывается струей, часто толчкообразно; цвет ее яркокрасный. Прижатие артерии центрального раны уменьшает и даже прекращает кровотечение.

**Лечение.** Временная остановка прижатием кровоточащего места стерильным перевязочным материалом. Если кровотечение не останавливается, больного надо немедленно отправить в больницу; при этом следует наложить давящую повязку (единственный метод предварительной остановки кровотечения на туловище).

Прижатия артерий. Применяется для временной остановки артериального кровотечения на конечностях, шее и голове. Прижатие производится выше места кровотечения в определенных точках, где артерия лежит не очень глубоко и может быть прижата к кости. Наиболее важные для прижатия точки: паховый сгиб — для артерии бедра; подколенная область — для артерии голени; подмышечная область и внутренняя поверхность двуглавой мышцы — для артерии руки; на шее у внутреннего края грудино-ключичной мышцы, близ ее середины — для сонной артерии; надключичная область — для подключичной артерии.

Наложение жгута. Основным способ временной остановки значительного артериального кровотечения на конечностях — круговое перетягивание конечности резиновым жгутом выше места кровотечения. При правильном наложении жгута пульс исчезает, артериальное кровотечение тотчас останавливается, и конечность бледнеет (восковидный вид). Чрезмерно тугое перетягивание может вызвать паралич и омертвление конечности. Можно оставлять жгут на конечности не более 2—2½ часов со снятием через час на несколько минут. В зимнее время надо защищать конечность от отморожения. Если раненого после наложения жгута отправляют дальше (например, в больницу), сопровождающим должно быть сообщено время наложения жгута.

Закрутка (перетяжка). Накладывают следующим образом: платок завязывают первоначально совершенно свободно; затем в петлю вставляют какую-нибудь палку или дощечку и закручивают платок до необходимой степени. При слишком тугом перетягивании и грубых, режущих перетяжках возможны осложнения — повреждение нервов конечности. При слабо наложенной перетяжке сдавливаются лишь вены, и кровотечение усиливается.

Окончательная остановка кровотечения. Наиболее надежный способ — перевязка сосуда путем перевязки его лигатурой. Если без расширения раны захватить кровотокающий сосуд не удастся, больной должен быть срочно направлен в больницу. При кровотечении из инфицированной, особенно гнойной раны и невозможности найти кровотокающий сосуд производят операцию перевязки артерии выше кровотокающего места.

Мероприятия при артериальном кровотечении: а) на протяжении конечностей — поднятие кровотокающей конечности и прижатие артерии на ее протяжении с последующим наложением жгута; б) у корня конечности — прижатие на протяжении или на месте ранения с последующей тампонадой, наложением жгута или давящей повязки; в) на туловище — прижатие на месте ранения с последующей тампонадой и наложением давящей повязки; г) на шее — прижатие на протяжении или на месте ранения с последующим наложением давящей повязки; на голове — прижатие на протяжении (реже) или на месте ранения (чаще) с последующей давящей повязкой.

Венозное кровотечение. **Симптомы и течение.** При ранении вен кровь льется непрерывно и равномерно, быстро заполняя рану. При образовании застоя (опускание кровотокающего органа вниз) кровотечение усиливается; прижатие вен между местом ранения и сердцем также усиливает кровотечение. Кровь, вытекающая при ранении вен, имеет темную окраску.

**Лечение.** Для остановки венозного кровотечения приподнимают кровотокающую область и накладывают давящую повязку.

Капиллярное кровотечение. **Симптомы и течение.** Отдельных кровотокающих сосудов не видно: кровь сочится, как из губки. По окраске кровь стоит на границе между артериальной и венозной. Капиллярное кровотечение быстро останавливается самостоятельно и имеет значение лишь при пониженной свертываемости крови (гемофилия, заболевания печени, сепсис).

**Лечение.** Прижигание кровотокающего участка термокаутером. С той же целью может быть применена электрокоагуляция. Местно применяют тампонаду с 3% перекисью водорода или с раствором адреналина (1:1 000). Средства, повышающие свертываемость крови, см. *Паренхиматозное кровотечение*.

Паренхиматозное кровотечение. Кровотечение при смешанном ранении мелких артерий вен и капилляров внутренних паренхиматозных органов (печени, селезенки, легких, почек) может быть очень обильным и продолжительным.

**Лечение.** Внутренние кровоостанавливающие средства, вызывающие сокращение сосудов: препараты спорыньи, экстракт гидрастиса — 25—40 капель внутрь, адреналин (супаренин) 1:1 000

0,5 мл под кожу. Чаще применяются средства, повышающие свертываемость крови: 1) препараты хлористого кальция (10% раствор внутрь по одной столовой ложке, внутривенно 5—10 мл 10% раствора); применять под кожу нельзя (кальций вызывает омертвление); 2) лошадиная сыворотка подкожно или внутримышечно по 20—40 мл; может быть взята и одна из лечебных сывороток (противодифтерийная, противостолбнячная) в тех же количествах; 3) переливание небольших количеств крови или плазмы (50—150 мл). Окончательная остановка кровотечения требует оперативного вмешательства.

**КРОВОТЕЧЕНИЕ КИШЕЧНОЕ.** Наблюдается при туберкулезных и брюшнотифозных язвах кишок, сосудистых опухолях, раковых опухолях кишечника, геморрое и т. д.

**Симптомы.** Неизменная кровь из нижнего отрезка кишечника (прямая кишка) изливается через задний проход. При кровотечениях из верхних отделов кишечника вначале наблюдаются признаки нарастающего общего малокровия: головокружение, слабость, жажда, помрачение сознания, ослабление и учащение пульса, падение кровяного давления, резкая бледность, нередко вздутие живота и боли в кишечнике. Через 1—2 суток появляется дегтеобразный стул (измененная в кишечнике кровь).

**Лечение.** Полный покой; хлористый кальций 10% 10—20 мл внутривенно, лошадиная сыворотка ил.\* любая антиоксидантная сыворотка (противодифтерийная, противостолбнячная) по 10—20 мл внутримышечно; лед на живот. Переливание небольших доз (гемостатических доз) крови (150—200 мл). Больному назначается голодание. Подкожно физиологический раствор, глюкоза.

**ЛИМФАНГОИТ (LYMPHANGOITIS). ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ.** Из тканевых щелей бактерии могут про-

никнуть в лимфатические пути и вызвать местное воспаление по ходу лимфатических сосудов. "Лимфангоит является одним из осложнений гнойного процесса.

**Симптомы и течение.** Повышение температуры, иногда до 40°, лихорадочное состояние, резкая болезненность в большей части тела, появление красных болезненных полос на коже больного члена по ходу поверхностных лимфатических сосудов. При этом воспаленные поверхностные лимфатические сосуды прощупываются в виде уплотненных и резко болезненных тяжей. Заболевание обычно ликвидируется в течение нескольких дней, если не влечет за собой воспаления лимфатических узлов. В некоторых случаях по ходу лимфатических сосудов могут образоваться гнойники, подлежащие вторичному вскрытию.

**Лечение.** Полный покой заболевшего органа. При заболевании лимфатических сосудов ноги — постельное содержание, а руки — шинная повязка. Кроме того, больную область прикрывают согревающим компрессом. При задержке гноя воспалительный очаг подлежит вскрытию с наложением хорошо всасывающей повязки. Сульфамиды по 0,5 через 4 часа, пенициллин по 50 000 единиц через 3 часа. Лечение основного заболевания, вызвавшего лимфангоит.

**ЛИМФАДЕНИТ (LYMPHADENITIS). ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ.** Вызывается стафилококками и стрептококками, попадающими через лимфатические сосуды в лимфатические узлы. Обычно поражаются ближайшие к месту гнойного заболевания лимфатические железы (локтевая и подмышечные железы на руке, подколенные и паховые при заболевании ноги, паховые при заболевании области промежности и ягодиц, шейные при заболевании на голове и т. д.). Заболевание обычно следует за лимфангоитом, но иногда начинается и без видимых воспалительных явлений в лимфатических сосудах.

**Симптомы и течение.** Увеличение узлов, появление болезненности, общие лихорадочные явления. Увеличение желез и их болезненность могут исчезнуть в 2—3 дня, но нередко возможно гнойное расплавление узлов, образование нарыва или флегмоны.

**Лечение.** Покой больной части тела и согревающий компресс или сухое тепло (грелка, лампа соллюкс и т. п.). При образовании гноя — разрез. В дальнейшем заболевание лечат, как абсцесс (см.).

**Профилактика.** Правильное лечение местного гнойного процесса, своевременное раскрытие гнойника и флегмоны для выхода наружу гноя и покой заболевшей части тела. Разъяснение необходимости своевременного хирургического вмешательства, важности покоя и опасности движения и работы при наличии гнойного процесса.

**ЛИПОМА.** Доброкачественная опухоль из жировой ткани, чаще расположенная в подкожной клетчатке.

**Симптомы.** При осмотре и ощупывании — безболезненная, иногда множественная, мягкой консистенции, дольчатая опухоль, которая постепенно увеличивается в объеме.

**Лечение.** Хирургическое (иссечение).

**МАЛОКРОВИЕ ОСТРОЕ (ANAEMIA ACUTA).** На почве травматического кровотечения. Причина смерти от кровотечения — это прежде всего недостаточность количества жидкости в кровеносном русле, плохое снабжение кровью сердца и головного мозга и нарушение газового обмена.

**Симптомы и течение.** Жалобы на слабость, жажду, потемнение в глазах, звон в ушах, головокружение. Бледность кожных покровов, особенно хорошо заметная на конечностях и ушах, похолодание кожи, особенно на конечностях, липкий, холодный пот. Пульс слабый, мягкий, очень частый, с трудом сосчитываемый и неуловимый (нитевидный пульс), падение температуры, ускоренное дыхание.

При продолжающемся кровотечении больной теряет сознание, развивается синюха, появляются общие судороги, а затем смерть. Во многих случаях внутренних кровотечений общее состояние больного заставляет заподозрить наличие кровотечения.

**Лечение.** Прежде всего надо остановить кровотечение. Недостаток жидкости в организме восполняется обильным ее введением: обильное питье (если больной в сознании), введение физиологического раствора поваренной соли через кишечник (простые и капельные клизмы), под кожу, лучше всего в вену. Самоперели-

вание крови (аутотрансфузия): больного кладут с опущенной головой и приподнятыми ногами; кроме того, туго забинтовывают конечности, начиная от пальцев и до основания, эластическими бинтами, выжимая таким образом кровь во внутренние органы.

Согревание больного, сердечные возбуждающие. После остановки кровотечения — массивные переливания одногруппной крови (плазмы и сыворотки) до 1 000 мл, или ВИС ! (Видово-неспецифическая сыворотка) повторить переливание в соответствии с содержанием гемоглобина в крови.

**МАСТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (MASTOPATIA).** Более часто в начале климактерического периода, иногда у более молодых, в молочной железе развивается фиброзная ткань и множественные кисты с кровянисто-коричневым мажеобразным или желто-зеленым тягучим жидким содержимым. Процесс появляется при обратном развитии железы и при гормональных расстройствах. Возможно влияние неполных и неправильных циклов (при повторных абортах).

**Симптомы.** Незначительные боли, иногда интенсивные, с отдачей в руку, усиливающиеся перед менструациями, опухлеобразное уплотнение железы или дольки ее, без резких границ, иногда увеличивающееся при менструации. Поверхность припухлости крупно- или мелкозернистая (сравнивается с мешком с дробью). Иногда увеличение регионарных желез. Возможно развитие в измененном участке раковой опухоли, почему процесс относят к предраковому состоянию.

**Лечение.** Поддерживающие повязки и покойное положение железы, гормональные препараты. При локализованном процессе во избежание просмотра развития раковой опухоли — оперативное удаление участка железы. При наличии выделения из соска (сечернирующая и кровотокающая железа), безусловно, показана операция.

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ ШВОВ.** При приготовлении материала для швов применяют различные способы.

Шелк обезжиривается в течение 12 часов в эфире и 12 часов в спирту, затем 5~ минут кипятится в растворе сулемы (1 : 1 000) и обеззараженными (одетыми в перчатки) руками наматывается (нетуго) на стеклянные катушки в один или два слоя. Шелк сохраняется в свежем растворе сулемы и перед операцией в таком же растворе кипятится 2 минуты.

Видоизменение этого способа: шелк кипятят в воде или 5% растворе карболовой кислоты в продолжение 5 минут, затем нетолстым слоем наматывают хирургически чистыми руками на катушки и кладут их на 12 часов в стерильную банку с эфиром с притертой пробкой. Стерильным пинцетом шелк переносят в такую же банку со спиртом, меняя его через 12 часов, одни сутки и двое суток. Сменив спирт последний раз, сохраняют в нем шелк в течение 8 суток, после чего он годен к употреблению. Перед операцией кипятят шелк в продолжение 2 минут в водном растворе сулемы (1 : 1 000).

**Обработка малахитовой зеленью.** Шелк наматывается на катушки не более чем в 3 ряда и опускается па 5 минут в кипящий 1% водный раствор малахитовой зелени. Затем

переносят его в стерильную банку с 90—95° спиртом, где и хранят до операции.

Нитки готовят по одному из указанных способов, предварительно отмыв с них воск и крахмал кипячением в течение получаса в растворе соды и простерилизовав их в автоклаве.

Кетгут. В течение 8 дней держат кетгут в маленьких моточках в банке с жидкостью.

Rp. Jodi puri  
Kalii jodati aa 1,0  
Ag. destill. 100,0  
MDS. Раствор для кетгута

Через 8 суток раствор меняется и кетгут хранится в новом растворе до употребления.

Сухой йодный кетгут: небольшие моточки кетгута обезжиривают в эфире, смачивают в 1% растворе йодистого калия и вешают на стеклянной стойке или на нитках в банке с притертой пробкой; на дно банки насыпают кристаллический йод (5,0). Через 5—7 дней кетгут готов к употреблению. Обработка малахитовой зеленью. Кетгут в моточках помещают в 1% раствор малахитовой зелени в термостат при 20—30° на 3 суток, затем стерильным пинцетом извлекают его и опускают в банку с 90° спиртом, которую держат в термостате 24 часа. Перенеся кетгут в другую банку со спиртом, сохраняют его там до употребления. МЕДИАСТИНИТ (MEDIASTINITIS). ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДОСТЕНИЯ. Вызывается гнойной или гнилостной инфекцией. Развивается при прободении пищевода инородными телами или при ранении его, а также при переходе воспаления с окружающих органов на средостение (флегмоны шеи, язвы и опухоли пищевода, остеомиелиты ребер и т. д.).

Болезнь распространяется чрезвычайно быстро, принимая характер септической инфекции. Предсказание исключительно тяжелое (очень большая смертность).

Симптомы. Тяжелое общее состояние, быстро нарастающая интоксикация, повышенная температура (при гнилостных процессах не достигает высоких цифр), не соответствующее температуре учащение и ослабление пульса. Боли за грудиной и в области позвоночника; болезненность и затруднения при глотании. Лечение. Срочная операция.

МОЗГА СДАВЛЕНИЕ (COMPRESSIO CEREBRI). Наблюдается в результате сдавления мозга осколками, гематомами, опухолями.

Симптомы и течение. Повышение внутричерепного давления, головная боль, рвота, затемнение или потеря сознания, напряженный замедленный пульс и очаговые явления с потерей функции (потеря способности говорить, судороги, параличи).

Лечение. Покой. Согревание тела. При беспокойстве — морфин (1 мл). Введение гипертонических растворов: 40% раствор-глюкозы в вену (30—40 мл) или в сочетании с глюкозой, или самостоятельно 5—10% раствор Natrii chlorati 30—50 мл. На голову — лед. При нарастающих явлениях сдавления — операция.

### III

Сотрясение мозга (commotio cerebri). Симптомы и течение. Сознание больного затемнено или при более тяжелых формах отсутствует. Больной плохо воспринимает окружающее, бледен, слаб, лежит неподвижно, не говорит, не двигает ни рукой, ни ногой. Головные боли. Все указанные явления при легких формах иногда могут пройти через несколько минут. В тяжелых случаях лицо больного бледно, кожа покрывается потом. Зрачки слабо или совсем не реагируют на свет. Мышцы расслаблены; наблюдается рвота и непроизвольное отделение кала и мочи; пульс редкий (до 50—60 ударов в минуту) или учащенный. Эти явления могут иногда исчезнуть через несколько часов. После сотрясения мозга может остаться нервная возбудимость, головокружения.

Лечение. Покой. Лежачее положение в течение 2—3 недель, даже при легких случаях сотрясения лед на голову, люминал 0,05, 4С% раствор глюкозы 30—40 мл в вену.

Ушиб мозга (contusio cerebri). Следствие тяжелых повреждений черепа с анатомическим нарушением целостности мозговой ткани при одновременном отсутствии повреждения костей и мягких тканей черепа и с расстройством деятельности мозга.

Симптомы и течение. Те же, что и при сотрясении мозга. При нарушении участка коры наступают периферические параличи и расстройства чувствительности.

Лечение см. Сдавление мозга. При нарастающих явлениях присоединившейся инфекции или сдавления осколками — операция.

МОЧЕИСПУСКАНИЯ РАССТРОЙСТВА. Расстройство мочеиспускания появляется от различного рода причин: в результате нахождения в мочевом пузыре и мочеиспускательном канале камней, нарушения иннервации мочевого пузыря, заболевания и травмы центральной нервной системы, воспалительных процессов в мочевом пузыре и др.

Расстройство мочеиспускания может проявляться в увеличении частоты позывов, что чаще всего бывает на почве воспалительных процессов, камней, а также новообразований в пузыре. Расстройство мочеиспускания только ночью наблюдается: у мужчин — при заболевании предстательной железы, у жен-шин — при заболеваниях матки и прямой кишки.

Днем учащение мочеиспускания может зависеть от заболеваний нервной системы (моча нормальная). Увеличение суточного количества мочи (полиурия) наблюдается при сахарном и простом мочеизнурении, ин\*герстициальном нефрите, нефросклерозе, гидронефрозе и т. п.

Задержка мочи (retentio urinae) может быть вызвана камнями в мочевом пузыре, при опухолях предстательной железы, при за\* заболеваниях и травме уретры, сужениях уретры на почве перенесенных заболеваний, в результате заболеваний нервной системы, при заболеваниях прямой кишки (рефлекторно).

Задержка мочи может развиваться остро и хронически. При хронически развивающейся задержке больные отмечают, что им приходилось до появления задержки при позыве к мочеиспусканию дожидаться появления мочи, натуживаться, моча шла вялой



струей в мочевом пузыре оставалась моча (остаточная моча) вследствие невозможности полностью его опорожнить.

Острая задержка мочи появляется чаще всего у больных с увеличением предстательной железы и требует срочного оперативного вмешательства.

Задержка мочи может происходить при наличии препятствий к оттоку мочи в мочеточниках и почках (камни); задержка вызывает почечную колику вследствие растяжения почечных лоханок.

Анурия, или полное прекращение выделения мочи. Наблюдается в силу нарушений или препятствий к оттоку мочи при нормальной функции самой почки (камни в мочеточниках, сдавление мочеточников опухолью и инфильтратами). Такая анурия называется экскреторной.

При различных заболеваниях почки вследствие нарушения ее функции наблюдается секреторная анурия. Рефлекторная анурия наблюдается при повреждениях почки, после операции на почке и мочевыводящих путях.

По клиническому течению анурию можно разделить на два периода: первый период характеризуется отсутствием мочи. Состояние больного в это время удовлетворительное. Больные отмечают жажду. Через 2—3 дня, а иногда через 7 дней наступает второй период — с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту, поносы; наступает спутанность сознания, затем возбуждение или, наоборот, сонливость; дыхание учащено, и выдыхаемый воздух имеет запах мочи. У больных появляется липкий пот, сухость языка и затруднение дыхания. Перед смертью появляются клонические судороги. Этот второй период называется уремии (см.).

Недержание мочи. Под недержанием мочи понимают такое состояние, когда у больного вытекает моча непроизвольно и больной не чувствует позыва к мочеиспусканию. Полное недержание мочи наблюдается при органических заболеваниях центральной нервной системы и указывает на нарушения функции мочевого пузыря. Недержание мочи может быть частичным, постоянным, временным и ночным. Недержание мочи указывает на нарушение физиологических функций пузыря. Ночное недержание наблюдается главным образом у детей.

Л е ч е н и е. Должно быть направленным на борьбу с основным заболеванием и причиной, вызвавшей расстройство мочеиспускания.

НАРКОЗ. Наркотические средства. Эфир (Aether pro narcosi). Прозрачная, бесцветная жидкость, быстро испаряется, легко воспламеняется; при стоянии на свету или в открытой банке разлагается. Пробы на чистоту: 1) фильтровальная бумажка, смоченная эфиром, после его испарения не должна давать никакого запаха (сивушные масла); 2) влажный налет, остающийся после испарения эфира в стеклянной чашечке, не должен давать покраснения синей лакмусовой бумажки.

Хлороформ (Chloroformium pro narcosi). Прозрачная, бесцветная летучая жидкость, испаряется медленнее, чем эфир, разлагается на свету. Пробы на чистоту: 1) растертый на ладони или налитый на фильтровальную бумажку хлороформ не должен давать запаха; 2) при смачивании синей лакмусовой бумажки не должен вызывать

ее покраснения; 3) должен оставаться прозрачным и не мутнеть от прибавления раствора ляписа.

Хлорэтил (Aethylum chloratum). Бесцветная, быстро испаряющаяся жидкость, легко воспламеняется.

Стадии усыпления. В п е р в о й с т а д и и : спутанность сознания, учащение пульса и дыхания при сохранении рефлексов и исчезновении чувствительности.

Во в т о р о й с т а д и и (период возбуждения): больной кричит, поет, иногда ругается; появляются судорожные движения в руках и ногах; больной старается сорвать маску, может вскочить со стола; сердечная деятельность учащается, дыхание становится более частым и глубоким, иногда шумным, зрачок расширяется, хорошо реагирует на свет.

В т р е т ь е й с т а д и и (глубокого сна): совершенно исчезает чувствительность, мышцы расслабляются, исчезают рефлексы, дыхание становится более спокойным, медленным, глубоким, пульс замедляется, зрачки суживаются, на свет не реагируют.

В ч е т в е р т о й с т а д и и (пробуждения): продолжительность различна, в зависимости от применявшегося наркотического вещества (наиболее длительна после хлороформа — от  $\frac{1}{4}$  до 2—4 часов), длительности наркоза, глубины сна и индивидуальности больного. Период пробуждения может сопровождаться сильным возбуждением, доходящим иногда до буйства.

Осложнения. 1. Шок от страха перед операцией и наркозом. Профилактика состоит в подготовке больного путем бесед и применения медикаментов. Назначают наркотики и успокаивающие средства, особенно нервным больным (морфин 0,01 за полчаса до наркоза, люминал или другие снотворные накануне операции).

2. О с т а н о в к а д ы х а н и я и сердца вследствие рефлекторного влияния раздражения окончаний тройничного и гортанного нерва на центры дыхания, сосудодвигательные центры и центр блуждающего нерва. Профилактика — не давать сразу больших количеств наркотического вещества, (удушающего способа наркоза) и постепенно увеличивать дозу.

3. Р в о т а. Для предупреждения попадания рвотных масс в дыхательные пути необходимо, чтобы больной был приготовлен к наркозу: желудок его должен быть пуст. Рвота появляется, когда наркоз неглубок и больной просыпается; при ее появлении поворачивают голову больного в противоположную от операции сторону, очищают рот и носоглотку. Освободив путь для воздуха, что определяется по характеру дыхания, углубляют наркоз.

4. А с ф и к с и я. При западении языка лицо больного становится синюшным, вздутым, ногти цианотичными, дыхание хрипящим; челюсти сжаты, межреберные промежутки и надключичные ямки при дыхании западают. Если не устранить препятствия, наступает вторичное ослабление и остановка дыхания: лицо больного бледнеет, судорожных явлений обычно не бывает. Зрачки расширяются, на свет не реагируют. Первичная остановка дыхания от наркоза чаще всего наблюдается у алкоголиков, особенно если период возбуждения очень длителен и тяжел. Профилактика: внимательно наблюдать за больным при наркозе, соответственно умень-

шать дачу наркотического вещества при признаках возможных осложнений (широкий, не реагирующий на свет зрачок).

Местные причины асфиксии необходимо возможно быстрее устранить: язык должен быть взят щипцами или на лигатуру и вытянут, глотка быстро очищена вытиранием или отсасыванием. Раздвигают передние зубы, закладывают ротаторасширитель между коренными зубами и раскрывают рот больного. Если после восстановления проходимость дыхательных путей дыхание не возобновилось, применяют искусственное дыхание. При рефлекторной остановке дыхания и при остановке вследствие передозировки, т. е. действия наркоза на дыхательный центр, наркоз немедленно прекращают, маску снимают с лица больного и делают возможно быстрее искусственное дыхание.

5. Падение и остановка сердечной деятельности. Ослабление деятельности сердца иногда нарастает постепенно; в других случаях пульс быстро изменяется, становится слабым, частым, еле уловимым, а затем и совсем исчезает; резкое побледнение больного; черты лица заостряются; зрачки расширяются, реакция их на свет исчезает; рот раскрывается, челюсть отвисает.

Необходимо прекращение наркоза, свежий воздух, подкожное введение кофеина и камфоры, эфедрина. Если не наступает быстрого улучшения, применяют искусственное дыхание, внутривенное вливание физиологического раствора и внутривенное и внутриартериальное переливание крови.

Противопоказания к применению наркоза. Тяжелые заболевания легких (особенно противопоказан эфирный наркоз), перерождение сердечной мышцы (особенно противопоказан хлороформный наркоз), заболевания крови (крайние степени малокровия), заболевания желез внутренней секреции (заболевания надпочечников), тяжелые заболевания почек, резкая степень общего истощения и др.

Наркоз внутривенный. Техника. В ампулу с порошком гексенала добавляют 10 мл дистиллированной воды и после растворения набирают в шприц. Введение в вену должно быть очень медленным: первые 5 мл вводят в течение 3, а иногда и более минут. Наркозный сон наступает моментально, без стадии возбуждения. При применении второй дозы гексенала в разведении 1,0 на 20 мл дистиллированной воды наркоз можно продолжить до 1\*/г—2 часов. При внутримышечном введении 2,0 гексенала в 10% растворе наркоз наступает через 15—20 минут. Пентотал применяется в 2,5—5% растворе. Опасность заключается в слишком быстром введении в вену раствора и передозировке его.

После окончания наркоза сон продолжается обычно несколько часов. В течение этого времени необходимо внимательно наблюдать за больным. Возможны обычные для наркоза осложнения (асфиксия, падение сердечной деятельности); после гексеналового наркоза иногда наблюдается тяжелое возбуждение.

Наркоз газовый. Закись азота (*Nitrogenium oxydulatum*) — бесцветный газ сладковатого вкуса, на паренхиматозные органы не действует, не понижает кровяного давления, не обладает местным раздражающим действием.

Стадии усыпления:

1. Начальная стадия — неприятных ощущений больной не испытывает, дыхание замедляется. Быстро наступает состояние легкого опьянения, засыпание и аналгезия.

2. Возбуждение короткое, приятное (веселящий газ); наступает в 10% случаев, преимущественно у алкоголиков.

3. Стадия сна — через 5—10 минут после начала наркоза, реакция на свет и роговичный рефлекс сохранены. Глубина сна средняя.

4. Пробуждение быстрое — через 1—2 минуты, без неприятных ощущений, без вторичного сна, аналгезия до 2 часов.

Наркоз дают натошак после введения морфина или пантопона.

Техника: вдыхание газа в смеси с воздухом (кратковременный наркоз) и с кислородом (длительный наркоз). Применяется смесь из 85% закиси азота и 15% кислорода с уменьшением закиси до 65%. Искусство дачи — в умении регулировать смесь. Следить за цианозом. Газовой смеси необходимо от 8 до 10 л в минуту.

Осложнение. Рвота, повышение кровоточивости, пототделение, цианоз.

Показания. Применим при кахексии, анемии, у тяжелых, истощенных больных с почечными, легочными и сердечными заболеваниями.

Циклопропан. Бесцветный газ действует, как чьякись азота, при небольшой концентрации (20% циклопропана и 80% кислорода) удобен для длительного наркоза. Ввиду раздражающего действия на слизистые начальная концентрация весьма слабая.

Наркоз — эфирное оглушение. Для небольших операций длительностью 15—20 минут применяется наркоз, называемый опьянением или оглушением (рауш-наркоз). На марлевую салфеточку или маску льют тонкой струей эфир или хлорэтил. После нескольких вдохов больной переходит в состояние оглушения.

Наркоз прямокишечный. Эфирно-масляный (разработан Н. И. Пироговым) (1 часть масла, 2—3, части эфира). Доза 25,0 на 10 кг веса тела больного.

Техника: клизма на ночь, вторая перед операцией, за 45 минут до клизмы вводят морфин, за 30 минут до операции — эфирно-масляную смесь, сначала 10—15 мл смеси; по прекращении жжения вводится остальная смесь. Сон наступает через 30—40 минут. Метод имеет преимущества перед ингаляционным наркозом при операциях на голове, лице, шее. Осложнения те же, что и при ингаляционном наркозе. Недостаток метода — невозможность регулировать наркоз и трудность дозировки. По окончании наркоза или при появлении тяжелых осложнений остатки эфира и масла вымывают сифонной клизмой.

Наркоз нарколоновый (трибромэтиловый алкоголь). Кристаллический порошок. Применяется в 3% растворе в воде при 35° (выше 40° разлагается). Приготавливается перед употреблением.

Перед дачей наркоза производится контрольная проверка: к 5 мл раствора добавляют две капли конгорота — должна появиться оранжево-красная, а не фиолетовая окраска. Дозировка 0,08—0,1 на 1 кг веса больного.

Подготовка та же. Сон через 30—40 минут, длительность наркоза от 30 минут до 1—1½ часов.

Осложнения. Фибриллярные подергивания, падение кровяного давления, западение языка, цианоз. При передозировке—асфиксия.

В посленаркозном периоде возбуждение и психические расстройства. Смертность относительно высокая.

При осложнениях удаление раствора из прямой кишки.

Противопоказания. Заболевания печени, почек, сепсис.

**НЕВРОМА (NEUROMA).** Разрастания, состоящие из элементов периферических нервов, чаще всего развивающиеся в месте пересечения (культе) нерва. Доброкачественные опухоли нервов называют невриномами.

**Симптомы и течение.** Округлая плотная опухоль, соответствующая месту пересечения или повреждения нерва, чрезвычайно болезненная при давлении. Иногда вызывает резкие боли при малейшем, даже температурном раздражении (каузалгии). Рост невромы затрудняет пользование конечностью (ношение протеза) из-за болей при надавливании на нее.

**Лечение.** При нарушении функции конечности, особенно при нахождении невромы в культе в местах давления протеза, необходимо оперативное ее удаление.

**НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА (ILEUS).** Причины: различные процессы в кишечной стенке (опухоли, рубцовые сужения), закупорка просвета кишки аскаридами или камнем, при инвагинации, перекручивание кишки (заворот), ущемление кишечной петли спайками, сдавление опухолями соседних органов, функциональные нарушения перистальтики и ряд других процессов. Различают острую и хроническую (перемежающуюся) кишечную непроходимость, полную и неполную, динамическую, вследствие паралича кишечной мускулатуры (паралитическая) или спазма ее (спастическая), механическую при наличии препятствия по тракту кишечника для прохождения содержимого. Механическая кишечная непроходимость проявляется в двух формах: 1) странгуляция, шзгда расстраивается кровообращение в брыжейке кишечной петли, и 2) обтурация, когда имеется только закупорка просвета кишки без нарушения питания петли.

**Симптомы и течение.** Сильные боли в животе, задержка испражнений и газов, вздутие живота, рвота. Отсутствие перистальтики (при параличе кишечной мускулатуры), очень бурное и быстрое развитие болезни, резкая интоксикация (побледнение больного, учащение пульса, цианоз), особенно при затруднении проходимости в верхних частях тонкого кишечника, и неравномерное вздутие (при расстройстве кровообращения в брыжейке кишечной петли). Усиленная перистальтика, видимая на глаз через брюшную стенку, менее быстро развивающаяся картина болезни (при закупорке просвета кишки без нарушения питания петли).

**Распознавание.** У некоторых больных, особенно при неполной непроходимости, распознавание затруднено в начале заболевания и в поздних случаях, когда развивается картина перитонита. Трудные для распознавания случаи, где определяется какая-

то катастрофа в брюшной полости, но характер ее остается неясным, объединяются под названием «острый хирургический живот» (см.).

**Лечение.** Нельзя применять слабительных, которые ухудшают состояние больного, и наркотиков, затрудняющих диагноз и затемняющих картину болезни. Первая помощь — сифонная клизма, инъекция 1 мл солянокислого атропина (0,1%). При отсутствии облегчения больной должен быть немедленно направлен на неотложную операцию. В противном случае больной погибнет от интоксикации или омертвения кишки и развития перитонита. Чем позднее доставлен больной, тем более сложна и опасна операция (резекция омертвевшей кишки).

**НОГОТЬ ВРОСШИЙ (UNGUIS INCARNATUS).** Чаще всего наблюдается на больших пальцах ног в результате неправильного роста ногтя (внедрение в мягкие ткани — врастание в ногтевой валик) и давления обуви.

**Симптомы и течение.** Вокруг вросшего ногтя на почве хронического воспаления развивается язвочка и разрастаются грануляции. Больные жалуются на боли и невозможность ходить.

**Лечение.** Ношение более свободной обуви. При воспалительном процессе — покой и ванны. В далеко зашедших случаях и при рецидивах оперативное лечение: иссечение боковой части ногтя вместе с грануляциями и ногтевым ложем под местной анестезией.

**НОМА. ВОДЯНОЙ РАК (NOMA).** Нома представляет некротический процесс, начинающийся со слизистых рта, щеки, десны, губы. Болезнь развивается обычно у лиц, истощенных или ослабленных перенесенной инфекционной болезнью (корь, тиф, дизентерия и т. п.). У взрослых нома наблюдается редко, в настоящее время она редко встречается и у детей.

**Симптомы.** Нома начинается язвенным гингивитом или с образования на слизистой щеки уплотнения или пузырька с мутным кровянистым содержимым. Затем появляется черное некротическое пятно, быстро увеличивающееся, а на месте пузырька появляется изъязвление.

Некроз распространяется в глубину и ширину, разрушая не только мягкие ткани, но иногда и кости.

Температура у больных высокая. Общее состояние очень тяжелое. Заболевание заканчивается часто смертельным исходом в течение нескольких дней. Реже больные выздоравливают. Остаются дефекты на местах некротизированных тканей, которые закрываются рубцом.

**Лечение.** Профилактикой заболевания является усиленное питание с дачей витаминов и своевременное лечение гингивита. Появившийся пузырек немедленно прижигают или коагулируют. Некротические ткани удаляют. Применяют смазывание 5% раствором хлористого цинка, промывают рот раствором марганцовокислого калия (1:1000—2 000). Вводят противогангренозную сыворотку. Пенициллин. Общее укрепляющее лечение.

**ОБЕЗБОЛИВАНИЕ** см. *Анестезия.*

**ОЖОГ (COMBUSTIO).** Возникает при действии на тело высокой температуры и ряда химических веществ: концентрированных

растворов щелочей, кислот, ляписа, хлористого цинка, медного купороса и некоторых медикаментов (йодной настойки).

**Симптомы и течение.** При ожоге I степени: краснота, припухлость кожи и болезненность; длительность течения ожога 2—3 дня; происходит полное возвращение к норме; иногда остается лишь потемнение обожженного участка кожи (пигментация) и его шелушение.

При ожоге II степени: образование пузырей с серозным содержанием на поверхности покрасневшей и припухшей кожи; поверхностный роговой слой кожи омертвевает, отслаивается и под ним накапливается экссудат; при лопании пузыря обнажается ярко-красный, болезненный, легко ранимый, склонный к инфицированию глубокий слой кожи; если удалось избежать инфекции, то через 4—5 дней пузыри лопаются и подсыхают или содержимое их рассасывается. Выздоровление наступает без рубцов в течение 1—2 недель; если осложняется инфекцией, на обнаженной поверхности эпителия появляются грануляции, заживление сильно замедляется.

Для ожога III степени характерно образование струпа: поверхностные слои кожи часто слущены, и их обрывки висят в виде ломотьев; более глубокие части кожи нечувствительны, превращены в жесткую буроватую, иногда совершенно черную массу. Заживление наступает после отделения омертвевших тканей и их отторжения. Срок заживления от нескольких недель до нескольких месяцев. Возможно гнилостное и гнойное заражение, кровотечения и общее истощение. Кожа заменяется рубцовой тканью, склонной к последующему сморщиванию и стягиванию окружающих тканей. При большой поверхности ожога полного заживления может не наступить, и остается участок грануляционной поверхности.

При обширных ожогах ( $\frac{1}{3}$  и у, поверхности тела) вследствие раздражения нервных окончаний и реакции нервной системы могут наступить тяжелые общие явления (шок). Больной очень возбужден, жалуется на сильные боли и жажду, возбуждение сменяется апатией и сонливостью, температура падает до 36—35,5°; появляется рвота, позывы к мочеиспусканию при отсутствии мочи или наличии концентрированной, богатой белком мочи; бред, теряется сознание, пульс слабеет, появляется бледность и цианоз. Смерть наступает при явлениях коматозного состояния (судороги, коллапс).

**Лечение.** При ожоге едкими веществами надо быстро облить поверхность ожога большими количествами воды; при ожоге негашеной известью обмыть место ожога каким-нибудь маслом, а при ожогах крепкими кислотами — растворами щелочи (2% содовый раствор, мыльная вода, известковый раствор) или присыпать его мелом, магнезией, зубным порошком; при ожогах щелочами облить пораженный участок слабыми растворами кислот (уксусной, лимонной). При ожогах I степени можно успокоить боли и жжение, применяя раствор марганцовокислого калия.

При ожогах II и III степени задача лечения состоит в предупреждении шока введением морфина и согреванием больного. Дается горячее питье. Для предупреждения инфекции обожженный участок прикрывают стерильной простыней или асептической повязкой. Вводится противостолбнячная сыворотка. Больных помещают в

теплые палаты (27—30°). Область ожога обрабатывают хирургически: кожу в окружности ожога протирают бензином или спиртом. Пузыри вскрывают, строго соблюдая правила асептики.

При лечении ожога открытым способом больного кладут на стерильное белье, область ожога оставляют открытой; над кроватью ставят сетку, покрытую стерильной простыней, под каркас помещают электрические лампочки для согревания больного.

При лечении закрытым способом накладывают мазевые повязки со стерильным вазелиновым маслом из эмульсии стрептоцида, сухого стрептоцида, парафиновые повязки. Общее лечение состоит во введении больному до 4—5 л жидкости в сутки, введения в вену 50 мл 20% раствора хлористого натрия, 40% раствора глюкозы, в переливании крови по 500 мл, пенициллинотерапии. Вводится внутри-венозная сыворотка В НС.

При небольших ожогах применяют стерильные повязки после смазывания места ожога 3% раствором марганцовокислого калия. При смене повязки отмачивают ее в ванне из слабого раствора марганцовокислого калия. На гранулирующие поверхности кладут мазевые повязки из мази Вишневского. Перевязки делают возможно реже. **ОЖОГ ПИЩЕВОДА (COMBUSTIO OESOPHAGI).** Вызывается случайным или умышленным проглатыванием крепких растворов кислот (серной, азотной, соляной, уксусной и др.) и щелочей (каустической соды). Ожог кислотами дает на слизистой оболочке струп; затрудняющий более глубокое проникновение кислоты в ткани. При ожоге щелочами струп не образуется и стенка пищевода поражается на большую глубину.

**Симптомы и течение.** Затруднение глотания, жгучие боли по ходу пищевода и в подложечной области, слюнотечение, рвота, затруднение дыхания, коллапс, своеобразный запах рвотных масс при отравлении азотной и уксусной кислотой. Струп, видимый обычно на слизистой рта, при действии серной кислоты бурого цвета, азотной — желтого, при остальных ожогах — серовато-белого цвета. В течение первых суток наблюдается значительная смертность при явлениях коллапса. В дальнейшие дни может наступить прободение желудка, перерождение паренхиматозных органов, особенно почек. Пораженная слизистая отторгается, образуется длительно заживающая гранулирующая поверхность и наступает рубцовое сужение пищевода.

**Лечение.** Немедленное промывание желудка и пищевода. При ожоге кислотами: щелочи — жженая магнезия в смеси с водой, известковая Ада, мыльная вода; зола, смешанная с водой (столовая ложка на стакан); белковая вода; обильное питье. При ожоге щелочами — слабые растворы лимонной и уксусной кислоты (столовый уксус). При болях — морфин. В дальнейшем необходимо раннее и длительное бужирование пищевода. **ОНИХИЯ** см. *Панариций*.

**ОПУХОЛИ ПОЧЕК.** Почки поражаются главным образом злокачественными новообразованиями и редко доброкачественными. Среди злокачественных новообразований (главным образом у детей) встречаются саркомы у взрослых, гипернефромы (в большей половине случаев) и рак почки (реже).

Саркомы почек у детей протекают без признаков и распознаются часто только при достижении значительных размеров. Дети погибают от кахексии и метастазов. Ввиду поздней постановки диагноза (продолжительное скрытое течение) операция дает плохие результаты — если и удастся удалить опухоль, часты метастазы. Рентгенотерапия дает временное уменьшение опухоли.

Основные признаки гипернефромы — обильная и безболезненная гематурия, боль и прощупываемая опухоль. Может внезапно появиться боль непостоянного характера при закупорке мочеточника сгустком крови. В моче при гематурии находят длинные червеобразные сгустки — слепки мочеточника. Опухоль при прощупывании плотна, иногда бугристая. Постоянные боли указывают на растяжение капсулы почки опухолью и прорастание опухоли в ткани. Характерным является варикоцеле. Общее состояние больных долго остается хорошим. При распознавании необходима пиелография, цистоскопия (для исключения опухоли мочевого пузыря). Предсказание неблагоприятное.

**Лечение.** Удаление почки. Рентгенотерапия не дает хороших результатов.

**ОРХИТ (ORCHITIS).** Воспаление яичка. Возникает при различных заболеваниях (паратифе, тифе, ангине) или может перейти с воспалительного процесса придатка самого яичка. Инфекция может попасть в яичко гематогенным путем. Орхит наблюдается также как последствие травмы яичка.

**Симптомы и течение.** Яичко увеличено и болезненно, особенно при ощупывании. Температура значительно повышена. Общее состояние больных нарушено. В большинстве случаев при лечении воспалительный процесс постепенно убывает, но в некоторых случаях в яичке образуется гнойник.

**Лечение.** В остром периоде полный покой с постельным пребыванием. Фиксация мошонки в высоком положении повязкой или суспензорием. Тепло. При болях — свечи с белладонной, морфин, пантопон. При гнойнике — хирургическое вмешательство.

. Rp. Extr. Belladonnae 0,015 But.  
Cacao 1,5 M. f. suppos. D. t. d.  
N. 6 S. По г- свече при болях

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici 1% 1,0 in amp. DS. По  
1 мл под кожу

**ОСТЕОМИЭЛИТ. ВОСПАЛЕНИЕ КОСТНОГО МОЗГА И КОСТИ.** Остеомиелит острый (osteomyelitis acuta). Вызывается чаще стафилококками, попадающими в костномозговую полость с током крови из другого какого-либо гнойного очага или через открытые повреждения с нарушением целостности надкостницы и кости (остеомиелит травматический). Развивается острый воспалительный процесс. Гной по костным каналам распространяется на надкостницу, отслаивая ее. При прорыве надкостницы гной распространяется в межмышечные пространства, вызывая флегмонозный процесс. Тромбируются сосуды кости и наступает ее частичное

омертвение. Отделившаяся мертвая кость лежит в виде инородного тела (секвестр). От надкостницы происходит образование новой кости. Секвестр оказывается окруженным костной тканью. При омертвении кости может наступить патологический перелом.

**Симптомы и течение.** Начинается внезапно потрясающим ознобом, резким повышением температуры и тяжелым общим состоянием. Одновременно появляются резкие боли в области пораженной кости. Местное повышение температуры, небольшая отечность и резкая болезненность. Рентгенологическое исследование может указать на поражение кости через 10—12 дней после начала заболевания. При прорыве гноя в межмышечные промежутки заболевание принимает характер глубокой флегмоны. Осложнения: гнойное воспаление ближайших суставов и общее заражение.

**Лечение.** Применение сульфаниламидных препаратов и в особенности с предварительным отсасыванием гноя из субпериостального гнойника и промыванием его пенициллином с последующим введением его внутримышечно; иммобилизация и при сформировании секвестров — оперативное лечение (секвестротомия).

**Остеомиелит хронический (osteomyelitis chronica).** При переходе в хроническую форму в кости образуются гнойные полости с секвестрами.

При остеомиелитах после огнестрельных ранений процесс распространяется на значительные участки кости, в него вовлекаются поврежденные мягкие ткани; местный процесс протекает тяжело и не склонен к самоизлечению.

**Симптомы и течение.** Свищи с гнойным, часто-ихорозным отделяемым, идущие к кости. При введении зонда в свищ нередко ощущается шероховатая кость. На рентгеновском снимке обычно видна полость, находящаяся в ней секвестры и уплотнение кости в окружности. Свищи могут закрываться; возможны обострения болезни (рецидивирующий остеомиелит): свищи открываются вновь. Это особенно характерно для остеомиелитов после огнестрельных ранений, где рецидивы встречаются через много лет после ранения. При длительном течении остеомиелита возможно развитие раневого истощения и поражения внутренних органов, особенно почек (амилоидоз).

**Распознавание.** Необходимо дифференцировать хронический остеомиелит от туберкулеза костей и суставов и от сифилитического их поражения. Диагноз значительно облегчается изучением анамнеза развития процесса и рентгеновским снимком.

**Лечение.** перевязки и уход за кожей в окружности свищей. Физиотерапевтическое лечение: кварц, соллюкс, солнцелечение; торфо-и грязелечение. При наличии секвестров — оперативное лечение, в некоторых случаях повторное.

**ОСТИТ ФИБРОЗНЫЙ.** Рассасывание костной ткани с замещением ее фиброзной тканью и образованием кистозных полостей.

Благодаря истончению наружного, компактного вещества кости в очаге поражения возможен патологический перелом.

Этиология неясна, возможно нарушение функции паращитовидных желез. Может быть поражение нескольких костей.

**Симптомы.** Боли в области поражения кости, плотная, медленно увеличивающаяся припухлость, нарушение функции конечности.

Заболевание диагностируется только путем рентгенологического исследования. На рентгеновском снимке видны кистозные образования в кости и истончение ее.

**Лечение** хирургическое.

**ОСТРЫЙ ЖИВОТ.** Под этим названием объединяется ряд острых заболеваний брюшной полости и забрюшинных органов: всевозможные перитониты, прободения язвы желудка, червеобразного отростка слепой кишки, желчного пузыря, фаллопиевых труб; язвы кишок; воспалительные заболевания органов брюшной полости (аппендицит, холецистит, панкреатит и т. д.); кишечная непроходимость в результате внутреннего ущемления, заворотов и перегибов кишечной петли, внедрение, закупорка кишки опухолью и т. д.; внутренние кровотечения и разрывы органов (трубы при внематочной беременности, селезенки, печени, кишки); тромбозы сосудов кишечника.

**Симптомы:** 1) острые постоянные или схваткообразные боли в животе; 2) непрекращающаяся тошнота и рвота; 3) длительная задержка стула; 4) резко вздутый или доскообразно напряженный живот; 5) изменение общего состояния: бледность, иногда цианотичность, холодный пот, беспокойство, учащение и падение пульса.

**Распознавание.** Необходимо исключить рефлекторные симптомы при заболевании органов грудной полости (пневмония, плеврит, стенокардия) и колики (печеночную, почечную, кишечную), где оперативного лечения не требуется. Диагноз уточняется с помощью рентгенологического и лабораторного исследования.

**Лечение.** Противопоказаны наркотики и слабительные. Допустимы клизмы, лучше сифонные (при отсутствии кровотечения и признаков перитонита), необходима немедленная операция.

**ОТМОРОЖЕНИЕ (CONGELATIO).** Отморожение может наступить при температуре около 0° и даже выше.

Отморожению способствует холод, тесная или влажная долго не снимавшаяся обувь. Громадное значение имеет и общее состояние: истощение, малокровие, понижение деятельности сердца (у больных, раненых). Наиболее часто отмораживают пальцы нижних конечностей и верхних конечностей, уши и кончик носа.

**Симптомы и течение.**

I степень: нерезкое сокращение (спазм) сосудов, вызывающий побледнение кожи и потерю чувствительности. После согревания кожа становится синюшно-красной (паралич сосудов), болезненной и отекает.

II степень: после согревания побледневшего участка кожи тела на нем появляются пузыри, часто с кровянисто-серозным и мутным содержимым; кожа вокруг пузырей имеет синюшно-красную окраску.

III степень: глубокие расстройства кровообращения; участки кожи, лишенные питания, погибают и омертвевают. Такие глубокие

### III

расстройства питания выявляются лишь через несколько дней, так как первоначально отмороженная часть имеет сине-багровый цвет, покрыта пузырями, струпами.

IV степень: омертвление не только кожи, но и подлежащих тканей.

Гангрена при отморожении легко приобретает влажный характер. В других случаях ткани становятся бурочерными и твердыми (сухая гангрена).

Отморожения III и IV степени заживают очень медленно.

**Лечение.** Первая помощь: дезинфекция кожи спиртом; для восстановления кровообращения — осторожный массаж рукой в стерильной резиновой перчатке, смазав отмороженный участок стерильным вазелином. Массаж должен быть нежным, и его можно усилить только после появления признаков восстановления кровообращения. При первой помощи до восстановления кровообращения отмороженную часть тела согревают в теплых ваннах (35—37°), сопровождая согревание легким массажем, тепло укутывают, дают внутрь теплое питье.

После восстановления кровообращения (покраснение и потепление) кожу обрабатывают спиртом и накладывают асептическую повязку с большим количеством ваты (утепление).

Лечение проводится различно, в зависимости от степени отморожения. Основная задача — предупреждение развития инфекции.

Лечение отморожений I степени — перевод больного в теплое помещение, мажевые повязки.

При отморожении II степени после обработки кожи спиртом пузыри полностью удаляют, сгусток фибрина слегка просушивают марлей и накладывают асептическую повязку на 5—10 дней.

При отморожениях III, III и IV степени задача лечения заключается в предотвращении инфекции, для чего вводят противостолбнячную сыворотку, прорезают пузыри при условии соблюдения строжайшей асептики, накладывают сухие и асептические повязки, мажевые повязки, повязки из стрептоцидной эмульсии и др. Участки ткани с гангренозными поражениями смазывают йодной настойкой. Боли уменьшают с помощью наркотиков и суховоздушных ванн. Для улучшения кровообращения пострадавшие конечности приподнимают (подвешивают). При осложнении инфекцией и для предупреждения ее — сульфаниламидные препараты и пенициллин.

При отморожениях III и IV степени на конечностях раскрывают некротические ткани (некротомия) или иссекают их (некрэктомия). При наличии демаркации и улучшения кровообращения выше места омертвления производят ампутацию.

**ПАНАРИЦИЙ (PANARITIUM).** Гнойные воспаления пальцев кисти вызывает инфекция, проникающая при повреждениях, ранах, уколах, трещинах, занозах, маникюре и т. п. В начальной стадии панариций чаще всего представляет флегмону подкожной клетчатки пальцев, которая состоит из плотных соединительнотканых тяжей, идущих от поверхности кожи в глубину к надкостнице или сухожильному влагалищу. Между этими прилегающими друг к другу волокнами располагается жир (жировые дольки). Образовавшийся гнойный выпот заполняет пространства между тяжами сое-

динительной ткани, и увеличение его давления является причиной напряжения тканей и жестоких болей. Такое строение препятствует свободному распространению гноя, почему гнойный процесс вызывает омертвление клетчатки и переход нагноения на фалангу или сухожильное влагалище. В более легких формах гнойный процесс протекает в толще кожи между эпидермисом и сосочковым слоем, отслаивая эпидермис и образуя пузырь.

**Панариций кожный** (*panaritium cutaneum*). Симптомы и течение. Гнойный процесс развивается между поверхностным слоем (эпидермисом) и сосочковым слоем кожи. Эпидермис отслаивается, образуется пузырь; его содержимое — желтый гной или мутная кровянистая жидкость. Гнойные пузыри могут сопровождаться тяжелыми лимфангоитами. Чаще всего эта форма встречается на концах пальцев руки даже после незначительных повреждений.

**Лечение.** Вскрытие пузыря, после чего срезают весь отслоенный эпидермис. После удаления пузыря накладывают повязку с индифферентной мазью или эмульсией стрептоцида.

**Панариций костный** (*panaritium ossale*). Развивается самостоятельно или при переходе процесса на кость при других формах панариция.

**Симптомы и течение.** Жалобы на жестокие пульсирующие боли. Область фаланги припухает. Температура повышается. Краснота может отсутствовать. Палец слегка согнут в соседнем с фалангой суставе. В дальнейшем гной прорывается (чаще на вершине пальца). Из образовавшегося свища после прорыва гноя выпирают грануляции. При зондировании можно обнаружить изъеденную кость. Фаланга может выделиться в виде секвестра.

**Лечение.** Вскрытие гнойного очага. При секвестрировании секвестр фаланги удаляют.

**Панариций ногтевой** (*panaritium unguis*) представляет собой форму подкожного панариция в околоногтевом или ногтевом ложе. Входными воротами инфекции служат заусеницы, занозы, повреждения при маникюре.

**Симптомы и течение.** Различают острый (воспаление ногтевого ложа) и паронихию (воспаление тканей, окружающих ноготь). При паронихии находят припухлость и красноту на ногтевом валике, при давлении на который больные жалуются на резкую боль. Боли и воспалительные явления увеличиваются при переходе гнойного процесса под ноготь, через который может просвечивать гной. Гной, прорвавшись сбоку или со стороны ложа ногтя, оставляет углубление, в котором развиваются грануляции.

**Лечение.** Ранний разрез. При наличии гноя под ногтем частичное или полное удаление ногтя. В самом начале можно применить теплые ванны, компрессы из спирта (50°) и мажевые повязки.

**Панариций подкожный** (*panaritium subcutaneum*). Симптомы и течение. Гной находится в подкожной клетчатке, на ногтевой или срединной фаланге. Больные жалуются на пульсирующую боль. Палец отечен, гиперемирован, находится в полусогнутом положении. Краснота и припухлость распространяются на тыл кисти, но эта припухлость менее болезненна. В благоприятных случаях гной прокладывает путь через кожу. В более тяжелых

### К случаям гнойный

воспалительный процесс может распространиться на кость (костный панариций) и сустав (суставный панариций) или на сухожильное влагалище, а также на тыл кисти и ладонь, вызвав флегмону ладони. Панариций сопровождается иногда высокой температурой (до 39—40°).

**Распознавание.** Производится на основании анамнеза, жалоб больного на пульсирующие боли и боли при давлении на ограниченном участке. Дифференцировать от тендовагинита (симметричность расположения припухлости по ходу сухожилия, резкая болезненность при попытках разогнуть палец).

**Лечение.** Ранний разрез (обязательно обезболивание) еще в стадии инфильтрации, не дожидаясь формирования гнойника (оперативное вмешательство должен производить хирург). После операции в рану вводят полоску марли (можно с мазью) и накладывают повязку на 2—3 дня. В дальнейшем повязки и полоски марли меняют.

**Панариций суставный** (*panaritium articulare*). Возникает в результате перехода гнойного процесса при костном панариции или воспалении сухожилия, в некоторых случаях от травмы (костная рана).

**Симптомы и течение.** Резкие боли, усиливающиеся при движении в суставе. В дальнейшем движения становятся невозможными. Палец находится в полусогнутом положении. При давлении или потягивании за палец боли усиливаются. Сустав опухает. Патологическая подвижность указывает на разрушение боковых связок.

**Лечение.** Необходим разрез с обеих сторон сухожилия.

При значительных разрушениях костей пальца приходится прибегать к ампутации.

При всех видах панарициев можно применять пенициллинотерапию.

**ПАНКРЕАТИТ (PANCREATITIS).** Воспалительный процесс в поджелудочной железе вызывается инфекцией или застоем секрета и ведет к кровоизлияниям в железу и некрозу ткани железы. Нередко панкреатит развивается как осложнение желчнокаменной болезни, иногда у больных, страдающих ожирением, вслед за принятием обильного количества пищи и употреблением алкоголя.

**Симптомы.** Различают острый (геморрагический, серозный и гнойный), подострый и хронический панкреатит. Геморрагический панкреатит сопровождается геморрагическим выпотом и белыми бляшками на брюшине.

Острый панкреатит развивается при картине острого живота, напоминающей кишечную непроходимость. Характерны жестокие боли в животе и спине, тяжелое общее состояние, нарастающая интоксикация, цианоз, падение пульса, рвота, вздутый напряженный живот, задержка стула и газов, лейкоцитоз. В течение одних-двух суток заболевание заканчивается летальным исходом.

Для хронического панкреатита характерны неопределенные боли в брюшной полости, иногда прощупываемая болезненная,

плотная опухоль, соответственно положению железы. Нередки периодические обострения.

Распознавание трудное, правда, его можно облегчить путем определения диастазы в моче (увеличение).

**Лечение.** Немедленная госпитализация по подозрению на острый панкреатит для оперативного лечения. При хронических панкреатитах тепло, глюкоза с инсулином, антибиотики.

**ПАРАНЕФРИТ (PARANEPHRITIS). ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОПОЧЕЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ.** Возникает вследствие попадания инфекции (стафилококк, кишечная палочка, стрептококк) гематогенным путем или из другого гнойного очага (фурункул, карбункул, остеомиелит, панариций, ангина), либо непосредственно с соседних тканей и органов, либо через лимфатические сосуды и после гнойного заболевания почки (инфицированные камни почек, пиелонефроз, карбункул почки, туберкулез почки), а также при предшествующих заболеваниях червеобразного отростка, плевры и т. п. Паранефриты делятся на две формы: почечного и внепочечного происхождения.

**Симптомы и течение.** Болезнь начинается остро ознобом, повышением температуры. Боли могут вначале отсутствовать, а в дальнейшем появляются в почечной области. Брюшная стенка может быть напряжена. Ощупывание области почек болезненно. Появляется симптом Пастернацкого. Иногда не совсем ясно прощупывается как будто увеличенная и болезненная почка, в действительности же инфильтрат. Позднее появляется асимметрия области почек (выпячивание, краснота и отечность). Переход гнойного процесса на фасцию подвздошно-поясничной мышцы характеризуется сведением йоги в тазобедренном суставе.

**Распознавание.** Гной в моче (при паранефрите почечного происхождения); пиелография, хромоцистоскопия и рентгеноскопия помогают распознаванию.

**Лечение** в большинстве случаев оперативное. В легких случаях — грелки, компрессы. Стрептоцид, пенициллин.

**ПАРАПРОКТИТ (PARAPROCTITIS). ВОСПАЛЕНИЕ КЛЕТЧАТКИ ОКОЛО ПРЯМОЙ КИШКИ.** Инфекция попадает в клетчатку вокруг заднего прохода через раны, трещины, ссадины кожи около заднего прохода или слизистой оболочки прямой кишки. Гнойное воспаление бывает ограниченное или распространяется на значительном протяжении. Образующиеся около прямой кишки гнойники вскрываются наружу вблизи заднего прохода или в прямую кишку, или одновременно и наружу, и в кишку.

**Симптомы и течение.** Жалобы на боли при испражнении и запоры. Повышение температуры. Около заднего прохода болезненная припухлость. Образующиеся после самопроизвольного вскрытия свищи вызывают боль при испражнении и загрязняют белье.

**Лечение.** Раннее оперативное вскрытие инфильтрата или сформировавшегося гнойника. До формирования гнойника — очищение кишечника слабительными (касторкой, английской солью), сульфаниламидами, пенициллин, грелки. При болях — паркетки

(морфин, пантопон) подкожно, микроклизмы или свечи с пантопоном (0,02).

Rp. Decocti Amyli tritici 5,0 : 100,0

T-rae Oprii simplicis 0,3

DS. Для микроклизмы

Для задержки стула первые 5—6 дней после операции настойка опия по 5—8 капель 3 раза в сутки.

**ПАРАФИМОЗ** см. *Фимоз*.

**ПАРОНИХИЯ** см. *Панариций*.

**ПАРОТИТ ГНОЙНЫЙ (PAROTITIS PURULENTA). ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ЗАУШНИЦА).** Вызывается гнойными микробами (стафилококками и стрептококками), попадающими из полости рта по слюнным протокам (возможно, и по кровеносным сосудам). Нередко является осложнением тифов (особенно сыпного) и после операции у тяжелых хирургических больных. Развивается при плохом уходе, особенно если больному по характеру заболевания или операции не дают пищу через рот в течение нескольких дней (мозговые больные, желудочные больные).

**Симптомы.** Боли в околоушной области, затруднение при открывании рта, болезненная плотная припухлость в околоушной области, оттопыривающая мочку уха, повышение температуры, ухудшение общего состояния, лейкоцитоз.

**Профилактика.** Уход за ртом у тяжелых инфекционных и послеоперационных больных. При запрещении есть — мнимое кормление (жевание сухаря, с последующим его выплевыванием), способствующее усиленному отделению слюны и очищению полости рта, оно препятствует проникновению инфекции по слюнным протокам.

**Лечение.** Пенициллин, сульфамиды, местно — кварц. Поднятие общего питания больного введением глюкозы внутривенно, подкожно и в клизмах. При отсутствии рассасывания в течение 2—3 дней больной подлежит операции.

**ПЕРЕЛОМЫ (RACTURAE).** Переломы трубчатых костей. Различают травматические и патологические переломы (разрушение кости инфекционным процессом или опухолью, значительно уменьшающей ее прочность). Возникают при сгибании кости, превышающем пределы ее эластичности; сдавлении кости; отрыве кости вследствие натяжения сухожилия; скручивании кости и ее раздроблении. Перелому подвергается кость в месте травмы (прямой перелом) и на значительном удалении (непрямой перелом). Различают переломы поперечные, косые, спиральные, вклиненные, компрессионные и скользящие.

**Симптомы.** Боль в момент травмы и после нее и невозможность пользоваться поврежденной конечностью, ограничение подвижности или полная ее неподвижность. Припухлость в области перелома, кровоизлияния, изменение конфигурации и оси конечности, укорочение ее, неестественная подвижность на протяжении кости. Обследование больного с переломом производится очень осторожно. В сомнительных случаях производят рентгенологическое исследование.



**Течение.** Срок образования костной мозоли различен, в зависимости от возраста и состояния больного, размера кости и правильности стояния отломков: от 15 дней для мелких костей до 2 $\frac{1}{2}$ —3 месяцев при переломе диафиза бедра. При огнестрельных переломах нередко развитие анаэробной или гнойной инфекции с прогрессирующим флегмонозным процессом, дающим затеки, вторичные кровотечения, сепсис. Внедрение инфекции в кость вызывает остеомиелит с образованием секвестров, свищей и переходом процесса в хроническое состояние.

**Лечение п.** Первая помощь: при закрытых переломах — осторожное установление отломков в правильное положение и наложение шинной повязки; при открытых переломах — наложение асептической повязки после смазывания кожи в окружности повреждения йодной настойкой с последующей шинной повязкой; торчащий отломок вправлять нельзя, так как вместе с ним в глубину раны может быть занесена инфекция. Больные подлежат операции; отломок вправляют лишь после соответствующей обработки его во время операции.

Первая помощь при огнестрельных переломах — наложение повязки для защиты раны от инфицирования, остановка кровотечения, временная иммобилизация (шинная повязка) и доставление пострадавшего в хирургическое учреждение. Лечение начинают с первичной обработки раны: рану мягких тканей широко раскрывают, удаляют инородные тела (пули, осколки костей, не связанные с надкостницей). После операции — иммобилизация гипсовыми повязками или вытяжение. В дальнейшем нередко необходимы вторичные оперативные вмешательства по поводу затеков, вторичных кровотечений, а иногда и ампутация конечности. Цель лечения — добиться прочного правильного сращения костных отломков с сохранением полной функции конечности. Основные моменты лечения — установка отломков в правильное положение (репозиция) и удержание их в таком положении до наступления сращения.

Вправление значительно облегчается расслаблением мышц. Обычно такое положение получается, если периферический отломок переместить по оси центрального. Репозицию производят потягиванием за периферический отрезок конечности при фиксации центрального конца помощниками. Вправление производят под местной анестезией 2% раствором новокаина с тщательным соблюдением асептики, вводя через вкол в место перелома новокаин. Вправление отломков может быть произведено и длительным вытяжением конечности.

Для различных переломов приходится применять различные методы лечения: гипсовые повязки, шины и вытяжение, смотря по месту и характеру перелома. При всех способах необходимо иметь в виду возможность движений в суставах при полной и непрерывной неподвижности хорошо вправленных отломков.

Переломы ключицы. Происходят в результате прямых и косвенных насилий, при падении на руку и т. п. В большинстве случаев бывают в передней трети ключицы или на границе средней и наружной трети. Внутренний отломок тягой мышц смещается вверх и кзади, наружный — вниз и кпереди.

**Лечение.** Для установки в правильное положение отломков приподнимают плечо, оттягивают его кзади и затем фиксируют повязками или накладывают шину Белера. Можно применять мягкую повязку с отведением плеча кзади в виде двух колец, наложенных на область плечевых суставов и стянутых сзади эластической тягой (резиновая трубка).

При таком положении периферический отломок ключицы приближается к внутреннему отломку. Повязку или шину надо держать до 30 дней.

Переломы ребер. Наблюдаются в результате ударов, ушибов, сдавлений грудной клетки. Бывают одиночные и множественные. Наиболее часты переломы IV—IX ребра. При переломе ребер может быть поражена плевра и легкое концами переломленных ребер; при этом образуется пневмоторакс, гемоторакс, подкожная эмфизема.

**Симптомы и течение.** Колющая боль при дыхании, кашель. Больная сторона грудной клетки отстает при дыхании от здоровой. При ощупывании ребер болезненность по ходу ребра и в месте перелома. При ранении легкого может появиться кровавая мокрота. При подкожной эмфиземе — крепитация.

**Лечение.** Для уменьшения дыхательных экскурсий грудной клетки накладывают тугую повязку (бинтом, полотенцем). Для уменьшения боли в область перелома вводят 0,25—0,5% раствор новокаина; назначают морфин, кодеин, омнопон. Вместо тугой повязки накладывают липкопластырные полосы от грудины до позвоночника таким образом, чтобы предыдущий ход липкого пластыря наполовину заклеивался последующим (приблизительно накладывают 6—10 полос). Больному придают полусидячее положение.

Переломы костей черепа. Наблюдаются в результате ушибов головы при военной, уличной и промышленной травме. Различают закрытые и открытые переломы. По формам переломы черепа делятся на переломы: 1) в виде трещин; 2) с осколками — с внедрением или без внедрения их в мозг (переломы с вдавлением и без вдавления); 3) дырчатые переломы с потерей костного вещества.

**Симптомы и течение.** Явления сотрясения мозга, боль, кровоизлияние. Могут наблюдаться парезы и параличи (например, при вдавлении осколков или образовании гематом над твердой или под твердой мозговой оболочкой) и повышение внутричерепного давления. При ощупывании получается ощущение вдавления, подвижность осколков. Для переломов основания черепа характерно кровотечение из носа и из наружного слухового прохода. Кровооттек указывает: 1) в области глаза на повреждение передней черепной ямы; 2) в зеве на повреждение передней и задней черепной ямы; 3) в области сосцевидного отростка на повреждение задней черепной ямы. Иногда наблюдаются разрывы барабанной перепонки. Могут наблюдаться и повреждения черепномозговых нервов. Возможны осложнения — абсцесс мозга, флегмоны мягких тканей, остеомиелиты.

**Лечение.** Покой. Борьба с явлениями сотрясения мозга (см.) и шока (см.). Горизонтальное положение: Для понижения внутричерепного давления внутривенно вводят гипертонические растворы

глюкозы (40%) 20—40 мл и Natrii chlorati (5—10%) 30—50 мл. При падении пульса — впрыскивание сердечных средств (кофеин, камфора и т. п.). Больного направляют в больницу. При переломах основания черепа голова должна быть слегка приподнятой. Не следует промывать слуховые проходы и нос. Тампонаду носа можно делать лишь при сильном кровотечении.

В тяжелых случаях — спинномозговой прокол. При переломах основания черепа профилактически сульфамидные препараты (сульфидин, сульфазол и др.) по 3,0—6,0 в сутки равными частями через 3 часа и пенициллин.

**ПЕРИОСТИТ (PERIOSTITIS). ВОСПАЛЕНИЕ НАДКОСТНИЦЫ.** Наблюдается нередко после ушибов. При присоединении инфекций развивается гнойный периостит. Хронический периостит — часто следствие и проявление третичного сифилиса.

**Симптомы и течение.** Наиболее часто периостит наблюдается и при ушибах голени, и при переходе воспалительного процесса с зуба. Боли на ограниченном участке кости, припухлость. При нагноении — краснота, повышенная температура, флюктуация.

**Лечение.** При остро протекающем периостите — тепло, покой. При образовании гнояника — вскрытие. При периостите на почве сифилиса — противосифилитическое лечение.

**ПЕРИТОНИТ (PERITONITIS). ВОСПАЛЕНИЕ БРЮШИНЫ.** Возникает при переходе гнойных воспалительных процессов с других органов (аппендицит, перфорация язв желудка и кишок, непроходимость кишок), при попадании инфекции при ранениях, во время операции, как метастазы при ангине, гнойных процессах и др.

**Симптомы и течение.** Пульс частый, малый. Вначале больные жалуются на икоту, срыгивание, затем появляется рвота. Вначале рвота бывает желудочным содержимым, затем желчью; в тяжелых случаях рвота учащается. Живот вначале напряжен, а затем резко вздут (паралич кишечника). В тяжелых случаях — сиплый голос. Нередко затруднение мочеиспускания, жажда. Острая боль в животе в начале заболевания. При ощупывании весь живот чувствителен, но наиболее сильная болезненность — в области входных ворот инфекции (правая подвздошная область при аппендиците, подложечная область при перфорации язв желудка и т. д.); напряжение мышц брюшной стенки (защита мышц), которое при ограниченных перитонитах выявляется над местом исходного пункта инфекции. Симптом Щеткина-Блюмберга (боль усиливается при отнимании руки после легкого давления при ощупывании живота).

Урчания не слышно (отсутствие перистальтики). Газы не отходят. Дыхание поверхностное, а затем затрудненное из-за метеоризма и высокого стояния диафрагмы. В тяжелых случаях (конечная стадия) расстройство дыхания наступает также и от токсического воздействия на дыхательный центр. В результате токсикоза в моче появляется белок, цилиндры, индикан, возникает желтуха.

В связи с потерей большого количества жидкости и расстройства кровообращения глаза западают, нос заостряется. Кожа покрывается холодным потом, язык сухой, появляется цианоз. Сознание

## Р

затемняется и, наконец, теряется. Перед потерей сознания у больных наблюдается возбуждение (эйфория).

**Распознавание.** При подозрении на перитонит не следует прибегать к впрыскиванию морфина. При дифференциальном диагнозе иметь в виду напряжение мышц (особенно прямых мышц живота) при воспалении легких и диафрагмальном плеврите.

**Лечение.** Немедленная операция. Одновременное введение больших количеств жидкости внутримышечно и внутривенно (физиологический раствор, 5—10% раствор глюкозы), переливание плазмы, введение ВНС. Сердечные средства, сульфамидные препараты и пенициллин (по обычным схемам).

**ПИОНЕФРОЗ(РК)NEPHROSIS).** Гнойное заболевание почки. Почка при пионефрозе увеличена в объеме, бугристая, на разрезе она представляет вид мешка с полостями, заполненными гноем и мочой.

**Симптомы.** Различают две формы пионефроза: открытую и перемежающуюся. При первой форме — отток мочи и гноя свободен. Моча гнойная. Температура нормальна или несколько повышена. Больные жалуются на головные боли, сухость во рту. Окраска кожи бледная. Увеличение в крови количества остаточного азота. Иногда наблюдаются диспептические явления, появляются постоянные тупые боли и тяжесть в пояснице. При перемежающемся пионефрозе, при котором имеются глубокие инфильтративные изменения в стенке мочеточника, вызывающие его сжатие, происходит периодически закупорка гноем мочеточника. Моча становится прозрачной, но состояние больного ухудшается. Повышается температура, усиливаются боли (характер колики), увеличивается лейкоцитоз. Далее температура падает до нормы, боли исчезают, общее состояние улучшается, но моча вновь становится гнойной.

**Распознавание.** Почка увеличена в объеме, болезненна, температура повышена. Симптом Пастернацкого выражен резко. Моча мутная, нередко щелочной реакции. Пиелография не всегда дает возможность получить представление о разрушении почки.

**Предсказание.** При двустороннем пионефрозе предсказание плохое, при одностороннем — прогноз лучше и зависит от состояния другой почки.

**Лечение.** При одностороннем пионефрозе показано оперативное вмешательство — удаление почки (нефрэктомия). При двустороннем пионефрозе применяется симптоматическое лечение. Ванны, диета, внутривенное введение хлористого кальция (5 мл 10% раствора через день), пенициллинотерапия.

**ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ЗАКРЫТЫЕ.** Наблюдаются при ударах в живот, падении с высоты, сдавлении органов брюшной полости колесом, буферами и т. д.

**Симптомы.** При разрыве паренхиматозных органов и внутреннем кровотечении — шок в момент травмы (головокружение, слабость, жажда, помрачение сознания, ослабление и учащение пульса, нарастающее падение кровяного давления, резкая бледность); болезненность и напряжение брюшной стенки (особенно резко выражены при повреждении печени), симптом Щеткина-Блюмберга — боль при быстром отнимании руки, надавившей на брюшную стенку, притупление в отлогих местах брюшной полости.

При повреждении кишечника — шок в момент травмы, сильные, не стихающие боли в полости живота, рвота, разлитое мышечное напряжение, живот втянутый, доскообразный, твердый, в дыхании не участвует; симптом Щеткина-Блюмберга.

**Лечение.** Срочная операция в обоих случаях; остановка внутреннего кровотечения (см.).

**ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА.** Различают: 1) растяжения и разрывы связок; 2) повреждения межпозвоночных дисков (хрящей); 3) подвывихи и вывихи позвонков; 4) переломы (тел, дужек, остистых и поперечных отростков).

При повреждении позвоночника мозг может быть сдавлен или разрушен отломками кости, а при открытых повреждениях — и инородным телом (пулей).

Различают переломы позвоночника компрессионные со смещением и без смещения, без нарушения и с нарушением целостности спинного мозга.

**Симптомы и течение.** В месте повреждения обнаруживают боль и выбухание; в тяжелых случаях — резкое искривление (кифоз) позвоночника. При изолированном переломе остистого отростка — локализованная болезненность по средней линии. При переломе поперечных отростков — резкая боль при давлении на поврежденный отросток на 2—3 поперечных пальца от средней линии, напряжение мышц. Больной падает больную сторону при движении; резкая болезненность при нагибании всего тела в противоположную сторону.

**Распознавание.** Важно тщательно собрать анамнез. Повреждения шейных сегментов (III, IV и V) вызывают остановку дыхания и смерть; повреждения на уровне шейного и поясничного утолщения — тяжелые параличи и расстройства функции мочевого пузыря и прямой кишки. При повреждениях с полным перерывом спинного мозга — расстройство иннервации, трофические расстройства, пролежни (в области крестца, пяток, локтя, лопаток); задержка мочи и последующее развитие цистита; задержка стула, (парез кишечника, парез брюшной стенки) и метеоризм. Ко всем этим расстройствам легко присоединяется инфекция (пролежни, флегмоны, остеомиелиты, пизлиты, воспаления легких и т. п.). Для подтверждения диагноза делают рентгеновский снимок.

**Лечение.** Действие кишечника регулируют клизмами и дачей слабительных. Вытяжение на жесткой койке с деревянным щитом, головной конец кровати поднимают и под ножки подкладывают специальные подставки или 2—3 кирпича (высота подъема 35—50 см). Вначале легкая гимнастика, а затем более сложные упражнения. Оперативное лечение показано для освобождения спинного мозга от сдавления отломками дужек и инородными телами. Для эвакуации на далекое расстояние больных укладывают в гипсовую кровать. При задержке мочи катетеризация с соблюдением строжайшей асептики.

**Профилактика.** Поддержание чистоты: места, где могут образоваться пролежни, протирать спиртом.

**ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.** Для предупреждения осложнений необходим тщательный уход и наблюдение за больным.

Для улучшения сердечной деятельности после тяжелых операций применяется камфора (например, на желудке; камфорное масло применяется в количестве по 2,0 несколько раз в сутки для предупреждения легочных осложнений), кофеин, дигален, эфедрин (1 мл 2% раствора).

При затруднениях дыхания, синюшности — вдыхание углекислоты из подушки через катетер, вводимый в ноздрю на 10—15 секунд (несколько вдохов), затем перерыв и снова вдыхание углекислоты, так повторяют несколько раз; вводят 1 мл 1% раствора лобелина под кожу. При параличе кишечника и метеоризме после брюшных операций — газоотводная трубка, сифонные клизмы, атропин 1:1000 1,0, эзерин (физостигмин) 1:1 000 1,0 под кожу; внутрь — карболен. При болях в первые дни после операции — наркотики (морфин, пантопон). Во избежание пролежней места постоянного давления (крестец, лопатки, области остистых отростков, гребешки подвздошных костей) протирают камфорным спиртом. При задержке мочи — грелку и уротропин по 0,5 три-четыре раза в день. При невозможности питания больного и введения достаточного количества жидкости через рот вливают подкожно или внутривенно до 3 000—5 000 мл физиологического раствора или 5% раствора глюкозы в сутки; те же растворы можно вводить в виде капельных клизм.

**ПОЧКА БЛУЖДАЮЩАЯ, ПОДВИЖНАЯ, СМЕЩЕННАЯ (KEN MOBILIS).** Наблюдается в результате иссудания и иногда под влиянием травмы. Чаще встречается в возрасте от 20 до 40 лет, преимущественно у женщин. Основной симптом — боли в пояснично-подвздошной области, обычно возникающие при физической работе, ходьбе, при вертикальном положении туловища и исчезающие при горизонтальном положении. Боли иррадируют в пах, половые органы и ногу. В некоторых случаях происходит перегибание мочеточника, вследствие чего возникает приступ почечной колики, сопровождающийся рвотой и защитным напряжением мышц. Количество выделяемой мочи во время приступа уменьшается. В моче немного белка и повышенное содержание лейкоцитов. Функция почки не нарушена. Распознавание подтверждается исследованием рентгеновыми лучами. Смещение почки иногда сопровождается диспептическими явлениями и запорами. Нередко болезнь осложняется пизлитом. Диагноз ставится на основании пальпации и анамнеза.

**Лечение.** Консервативное — ношение бандажа, усиленное питание; запрещение тяжелой физической работы. Оперативное лечение — подшивание почки к XII ребру или ушивание под почкой фасциального мешка и др.

**ПОЧКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ.** Наблюдаются при ударах, ушибах поясничной области или подреберья. В результате наступает разрыв ткани почки (трещины, надрывы, проникающие в лоханку) или отрыв отдельных частей почки.

**Симптомы и течение.** Боли в области почки, иногда припухлость в поясничной области. Основной симптом — обильная кровь в моче или небольшие следы. Количество мочи в случаях разрыва лоханки уменьшено. Распознавание облегчается хорошо собранным анамнезом и описанными выше симптомами.

**Лечение.** Вначале покой, лед, наркотики (морфин), сульфаниламидные препараты. В более тяжелых случаях—операция. При огнестрельном ранении (кровь в моче, выделение ее через рану) — хирургическое лечение.

**ПОЧКИ ТУБЕРКУЛЕЗ** см. *Туберкулез почки.*

**ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВОСПАЛЕНИЕ. ПРОСТАТИТ (PROSTATITIS).** Воспаление предстательной железы может быть катаральным, фолликулярным (отдельные гнойные очаги в железе) и паренхиматозным, дающим иногда абсцессы простаты.

**Симптомы и течение.** При катаральном простатите учащение и болезненность мочеиспускания. Наощупь простата несколько чувствительна; в моче — короткие нити и умеренное количество гноя. При фолликулярной форме эти симптомы выражены резче, в области промежности ощущается жар, в моче значительная примесь гноя, в железе иногда можно прощупать узелки. При паренхиматозном простатите — повышенная температура (до 39° и больше), общие лихорадочные явления, боли в промежности, усиливающиеся при дефекации, мочеиспускание частое, болезненное, иногда задержка мочи. Абсцесс может вскрыться в мочеиспускательный канал, в кишку или на промежность.

**Распознавание.** Увеличение и болезненность железы при ощупывании.

**Лечение.** Борьба с основным заболеванием (гоноррея). В острых случаях — сульфаниламидные препараты, пенициллин, постельный режим, послабляющие (ревень, лакрица), сидячие ванны, наркотики; при абсцессе — вскрытие. При хронических простатитах — массаж простаты.

**ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГИПЕРТРОФИЯ (HYPERTROPHIC PROSTATAE).** В возрасте около 60 лет и старше у мужчин нередко появляется симптомокомплекс нарушения акта мочеиспускания, зависящий от увеличения предстательной железы или ее части, которая вызывает деформацию просвета мочеиспускательного канала и нарушение оттока мочи из пузыря.

**Симптомы и течение.** Различают три стадии заболевания. Первая стадия — расстройства мочеиспускания (учащение, особенно по ночам); больной тужится при мочеиспускании, струя мочи вялая, прерывистая. После окончания мочеиспускания при катетеризации в пузыре оказывается 20—30 мл мочи (остаточная моча). Вторая стадия — количество остаточной мочи до 500—600 мл, ощущение неопорожненного пузыря, учащение мочеиспускания, постепенное уменьшение выводимой мочи. Для третьей стадии характерно такое растяжение пузыря, что больной не в состоянии помочиться, и моча выделяется по каплям, произвольно; наблюдается полная задержка мочи, тошнота и рвота.

**Лечение.** Предупреждением запоров, исключением из пищи острых блюд и употребления алкоголя удается получить улучшение самочувствия больного в ранних стадиях гипертрофии. Применяется 40% раствор уротропина 5—10 мл внутривенно, медвежьих ушки в виде микстуры. При задержке мочи необходимо местное применение тепла (сидячая ванна, грелки на область пузыря и промежность). При безрезультатности — катетеризация с особо тщательным

соблюдением асептики. Катетеризация производится резиновым катетером, а при невозможности его проведения — шелковым катетером со специальным изгибом и лишь в крайнем случае очень осторожно металлическим более толстым катетером, так как он легко может дать ложный ход. При получении хотя бы капли крови катетеризацию прекращают и мочу спускают пункцией пузыря. При остаточной моче — систематическая катетеризация с промыванием пузыря; при остаточной моче 200—300 мл — катетеризация один раз в сутки (перед сном); при большом количестве остаточной мочи — катетеризация два раза в сутки или введение катетера на 5—10 дней. При отсутствии улучшения — оперативное лечение. Общее укрепляющее лечение. В настоящее время применяется лечение метилтестостероном и сиизтролом.

Rp. Decocti folii Uvae ursi 10,0:180,0 Sir. simplicis 20,0

MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

**ПРОБОДЕНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ.** Гангрена пузыря с последующим прободением — осложнение острого холецистита. Прободение сопровождается явлениями шока и развитием последующего перитонита; боли и защитное напряжение мышц вначале локализуются в правом верхнем квадранте, а затем распространяются на всю правую половину и на весь живот.

**Лечение.** Немедленная операция.

**ПРОБОДЕНИЕ КИШЕЧНИКА.** Встречается при туберкулезных, брюшнотифозных (начиная с 3-й недели), особенно при амбулаторном тифе и других язвах кишечника, при инородных телах и воспалительных процессах.

**Симптомы.** Боли в животе, напряжение мышц по всему протяжению брюшной стенки. Симптом Щеткина-Блюмберга, падение пульса, рвота, тяжелое общее состояние. У истощенных, тяжелых брюшнотифозных больных симптомы мало выражены, может отсутствовать напряжение мышц брюшной стенки.

**Лечение.** Срочная операция.

**ПРОБОДЕНИЕ ПИЩЕВОДА (PERFORATIO OESOPHAGI).** Обычно встречается как осложнение при острых инородных телах пищевода и удаление инородных тел.

**Течение.** Воспалительный процесс в окружности пищевода, затем медиастинит (см.). \*

**Симптомы.** Резкие загрудинные боли и боли в спине, затруднение и болезненность глотания, повышение температуры (до 38—39°), лейкоцитоз, тяжелое общее состояние вследствие нарастающей интоксикации, учащение и падение пульса. Болезненность и припухлость на шее, нередко с появлением подкожной эмфиземы.

**Лечение.** Срочное хирургическое вмешательство. Устранить глотание через рот до операции.

**ПРОЛЕЖЕНЬ (DECUBITUS).** Возникает у слабых постельных больных на местах костных выступов, подвергающихся постоянному давлению при лежании.

**Симптомы и течение.** Сдавленное место краснеет в синее, лишается чувствительности и покрывается черным струпом, который медленно отторгается с образованием язвенной поверхности.

**Профилактика.** Мягкая, часто сменяемая подстилка; ежедневное протирание камфорным спиртом опасных для пролежней мест.

**Лечение.** Мазевые или сухие стерильные повязки, ванны, движение в постели. Освещение кварцевой лампой (эритемная доза).

Rp zinci oxydati 1)0

Adepis suilli 10,0

MDS. Смазывать пролежни

Rp. Ac. salicylici 1,0

Amyli tritici Zinci oxydati aa 2,0 Vaselini ad

50,0 MDS. Паста для смазывания пролежней

#### ПСЕВДАРТРОЗ (PSEUD ARTHROSIS). ЛОЖНЫЙ СУСТАВ.

Замедление сращения кости и образование ложного сустава наблюдаются при значительном смещении костей в очаге перелома и плохом их соприкосновении, а также при плохой иммобилизации, при попадании между отломками мягких тканей, больших дефектах кости, открытых переломах, нарушении питания кости и общих заболеваниях.

Костномозговая полость закрывается, концы костей атрофируются, плотные рубцовые ткани образуют нечто вроде сумки в окружности.

**Симптомы.** Довольно значительная подвижность в очаге перелома через 6 месяцев после перелома. Диагноз подтверждается рентгеновским исследованием.

**Лечение.** При замедленном сращении в срски до 6 месяцев — хорошая длительная иммобилизация при активной функциональной нагрузке на конечность, препараты кальция и витамины внутрь. После 6 месяцев — операция.

**РАЗРЕЗ ГНОЙНИКА (INCISIO).** Сущность операции при гнойных процессах состоит только в разрезе. Разрез производится брюшным или остроконечным скальпелем. Волосы на коже в области разреза сбриваются, операционное поле смазывается йодной настойкой, моются и дезинфицируются руки, производится местная ин-фильтрационная анестезия 0,25—0,5% раствором новокаина, иногда дается наркоз. Разрез делают достаточно широким, скальпель держат, как писчее перо, как столовый нож или как смычок, делают разрез обычно слева направо, следя за тем, чтобы на всем протяжении он был одинаковой глубины. Лучше производить разрезы не сразу на всю глубину, а последно: сначала кожи, затем подкожной клетчатки, фасций, апоневрозов, мышц и т. д.

При поверхностных разрезах после прокола стенки абсцесса скальпелем расширяют в стороны или тупым путем, или острым (ножницы, скальпель). При глубоких абсцессах после разреза

кожи во избежание повреждения сосудов и нервов в глубине, особенно в отечных инфильтрированных тканях, и возможном изменении топографии (смещение сосудисто-нервного пучка), раздвигают ткани в глубине тупым путем (зондом, закрытыми ножницами). При появлении гноя расширяют отверстие в стороны также тупым путем, особенно следя за тем, чтобы не остались невоскрытыми карманы. При возможном затруднении оттока гноя расширяют разрез или делают контрапертуры и параллельные разрезы. Рана в глубине не должна иметь вид колодца, а быть достаточно широкой, чтобы можно было на глаз захватить кровоостанавливающим зажимом всякий сосуд в глубине, пересечение которого может дать кровотечение.

**Направление разрезов.** Направление разрезов параллельно складкам кожи на лице и шее, параллельно сосудам и нервам, а иногда по ходу мышц на конечностях. В частности, разрезы в области околоушной железы делают по ходу веточек лицевого нерва, под нижней челюстью параллельно ее горизонтальной ветви, на шее преимущественно делают поперечные разрезы, особенно кзади от грудино-ключично-сосковой мышцы, где продольные разрезы пересекают кожные шейные нервы. Иногда на шее делают продольные разрезы по переднему краю грудино-сосковой мышцы, по ходу сосудисто-нервного пучка.

В подмышечной области делают продольные разрезы вдоль края большой грудной мышцы (при отведенной руке) или по длине плеча по внутренней его поверхности параллельно сосудисто-нервному пучку.

По наружной поверхности плеча лучше делать спиральный разрез по ходу лучевого нерва. В области локтевого сгиба, предплечья — разрезы продольные, на пальцах — см. *Панариций*.

**РАЗРЫВ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА.** Причины: ущемление менисков между суставными поверхностями костей при падении на колено или на ноги, резком повороте и др.

**Симптомы.** При травме обычно происходит кровоизлияние в сустав (см. *Гемартроз*) и сгибательная контрактура. При стихании острых явлений, уменьшении или ликвидации выпота остаются боли в области коленного сустава, особенно при неловком повороте или движении. Болезненность (при ощупывании) соответственно области травмированного мениска.

**Лечение.** Тугое бинтование колена после травмы. При ущемлении — аправление путем вращения согнутого колена. При частом повторении и упорстве страдания, лишающем больного трудоспособности, — удаление мениска.

**РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЯ.** Закрытые разрывы сухожилия происходят на месте перехода его в мышцу и еще чаще на месте прикрепления к кости, с отрывом иногда надкостницы или части кости, или происходит отрывной перелом кости. Чаще всего наблюдается разрыв разгибателя ногтевых фаланг руки. После разрыва ногтевая фаланга принимает полусогнутое положение и не разгибается активно.

**Лечение.** Фиксация фаланги в небольшой гипсовой повязке или фиксаторе (4—6 недель), а при разрыве сухожилия в других местах — сшивание,

**РАК (CARCINOMA)**, Первичный рак встречается в органах, где есть эпителий, метастазы — во всех органах без исключения. Наиболее часто поражается желудок, матка, молочные железы, кишечник, пищевод, кожа и язык. Часто наблюдается распад и изъязвление опухоли. Внешний вид изменяется в зависимости от места и характера развития опухоли: плотный инфильтрат, рубцовое сморщивание органа, язва с плотными, часто подрытыми краями и сальным, грязным, покрытым распавшейся тканью дном. Опухоль разрушает находящиеся по соседству ткани, давая прорыв из одного органа в другой.

**Симптомы и течение.** Симптомы разнообразны, смотря по тому, в каком органе развивается рак. Вначале больной не ощущает боли, почему и не обращает внимания на свое заболевание. Нарушение функции органа, общая слабость, исхудание, землистый цвет лица, сухость и сухость кожи, малокровие. Различают три периода: в первом периоде опухоль дает только местные проявления, во втором — распространяется на соседние органы и по лимфатическим путям до ближайших узлов; в третьем — отдаленные метастазы по кровеносной системе. Длительность — от нескольких месяцев до нескольких лет; более длительно протекают лишь раковые заболевания кожи и молочных желез.

**Профилактика.** Санитарное просвещение в целях раннего обращения за медицинской помощью, профилактические осмотры тех или иных групп населения старше 30 лет.

Санитарно-просветительная работа по раку Ч Ознакомление населения: а) с ранними признаками рака, с особенностями ракового заболевания, с бытовыми и профессиональными моментами, могущими способствовать появлению рака;

б) с болезнями, на почве которых может возникнуть рак (предраковое состояние), мероприятиями по профилактике рака и предраковых состояний (внедрение в массы основных гигиенических знаний по вопросам быта, личной гигиены, гигиены труда, питания и т. д.);

в) с необходимостью своевременного обращения за медицинской помощью и раннего лечения рака современными методами;

г) с задачами общественности в противораковой борьбе и с необходимостью преодоления неправильных представлений у населения о раке.

Главнейшие формы санитарно-просветительной работы по раку:

а) доклады, лекции, беседы, вечера вопросов и ответов, выступления на общих собраниях и по радио, индивидуальные беседы с больными в приемном кабинете, в ожидальне, в стационаре, консультации населения по вопросам раннего распознавания рака и о мерах профилактики, систематический инструктаж активистов Красного Креста и Красного Полумесяца и актива здравоохранения;

б) организация выставок, витрин с наглядным информационным материалом, демонстрация кинофильмов, диапозитивов, аллоско-

<sup>1</sup> По материалам Центрального института санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР.

пических лент, вывешивание плакатов, лозунгов, создание в уголках здоровья разделов по борьбе с раком;

в) раздача популярной санитарно-просветительной литературы, помещение в стенгазету, многотиражки, общую прессу статей и заметок о раке;

г) организация в местных библиотеках раздела «Литература по раку».

Санитарно-просветительную работу по возможности надо строить на местном материале: эффективность лечения рано распознанных случаев у местных жителей, местный статистический материал и т. д. Эта работа проводится во всех лечебно-профилактических учреждениях, избах-читальнях, клубах, красных уголках, школах (в старших группах), на общих собраниях, сходках, при подворных обходах и т. д.

Кроме профилактических осмотров, необходимы: а) полный охват подозрительных на рак больных и выявленных раковых больных; б) периодические осмотры подозрительных на рак больных;

в) своевременная госпитализация больных с ранними формами рака;

г) систематические наблюдения за больными, оперированными по поводу опухолей и лечившимися рентгеновыми и радиевыми лучами; д) организация специальных приемов для онкологических больных; е) хорошо организованный учет онкологических больных.

**Лечение** оперативное. Применение луче- Рентгена и радия. Медикаментозное лечение для борьбы с кахексией и кровотечениями из опухолей и для улучшения общего самочувствия. Послеоперационное облучение лучами Гентгена и радия для борьбы с возможно оставшимися клетками опухоли с метастазами и рецидивами<sup>1</sup>.

**Рак грудной железы (cancer mammae).** Симптомы и течение. Опухоль, ограниченная участком железы или захватывающая ее полностью, иногда сморщивающая железу и уменьшающая ее объем, нередко отграниченная от ее ткани, спаянная с кожей и глубжележащими тканями; «увеличение подмышечных желез. В ранней стадии имеется только незначительное уплотнение, иногда кровянистые выделения из соска.

**Распознавание.** В поздних стадиях болезни распознавание не представляет затруднений. Ранняя диагностика возможна при обязательном оперировании всех опухолей грудной железы, имеющих вид ограниченного узла. Иссечение участка железы с последующим фистулогическим исследованием во всех случаях уточняет диагноз и разрешает вопрос о необходимости более широкой (радикальной) операции по поводу рака грудной железы.

**Лечение.** Операция с до и последующим рентгеновским лечением. В поздних стадиях болезни результаты неудовлетворительны.

**Рак желудка (cancer ventriculi).** Рак чаще поражает при-вратниковую часть желудка, область малой кривизны, реже область входа в желудок и редко большую кривизну. Нередко опухоль рас-

<sup>1</sup> Подробно о методике лечения и диагностике рака см. *Методические материалы Министерства здравоохранения СССР, приказ № 284 от 12/IV 1950 г.*

полагается на задней и передней стенке желудка. Рак желудка возможен на почве каллезной язвы желудка. Дает метастазы (наиболее часто в печень).

**Симптомы и течение.** Болезнь развивается постепенно и может протекать без всяких признаков. Ранние признаки: долго длящиеся диспептические явления (чувство переполнения желудка, отрыжка после еды, отвращение к пище, склонность к рвоте). При опухоли в области привратника появляются признаки сужения его, боль, рвота, отрыжка. При исследовании — расширение желудка; иногда прощупывание опухоли. В дальнейшем: явления сужения становятся более резкими, боли становятся невыносимыми; после принятия пищи — рвота (иногда кофейной гущей), тягостная зловонная отрыжка (тухлыми яйцами); запоры; резкое исхудание; аппетит слабый. Уменьшение или полное отсутствие соляной кислоты, наличие молочной кислоты.

**Лечение оперативное.** При неудаляемых опухолях — гастроэнтеростомия. В случаях иноперабельных (не подлежащих операции) — симптоматическое лечение: соляная кислота, горечи; при сильных болях — инъекции морфина или пантопона.

Rp. Ac. hydrochloric! diluti Pepsini aa 4,0 Aq. destill.  
200,0 MDS. По 1 столовой ложке во время еды

Rp. T-rae Chinae compositae T-rae  
Ashagae aa 15,0 MDS. По 25 капель  
перед едой

Rp. Sol. Morphini hydrochlorici 1% 1,0  
Sterilis. D. t. d. N. 6 in amp. S. По 1 мл  
подкожно при болях

Rp. Sol. Pantoponi 2% 1,0  
Sterilis. D. t. d. N. 0 in amp. %  
S. По 1 мл подкожно при болях

Необходим тщательный уход и наблюдение за отправлениями всех органов (за полостью рта, чтобы не образовался стоматит, за кожей, чтобы не было пролежней, и т. д.).

**Рак пищевода (cancer oesophagi).** Опухоль развивается в начальной части пищевода, на уровне разветвления бронхов и у входа в желудок. В месте опухоли образуется изъязвление. Опухоль дает метастазы по лимфатическим путям в околощитовидные, трахеаль-ные, бронхиальные и лимфатические узлы у корня легкого, а по кровеносным путям — в легкие и печень. Опухоль суживает просвет пищевода.

**Симптомы и течение.** Жалобы на затрудненное глотание сначала твердой, а затем и жидкой пищи. Выпитая жидкость извергается обратно. Больные начинают голодать, худеют, приподнятая в складку кожа расправляется медленно. Иногда больные могут принимать не только жидкую, но и твердую пищу — временное появление проходимости пищевода вследствие распада опухоли.

Больные погибают при явлениях раковой кахексии и осложнений: аспирационной пневмонии, кровотечения при распаде сосудов опухоли, медиастинита вследствие прободения пищевода.

**Распознавание.** Проводится на основании нарастающего затруднения глотания, возраста больных, похудания. Рентгеноскопия или рентгенография уточняют диагноз.

**Лечение.** Ранняя операция (резекция пищевода). При зловонии, исходящем от больного при распаде опухоли, дают 1—2% раствор перекиси водорода через час. Против спазма пищевода — атропин, адреналин (1:1 000) 5—10 капель. При болях — морфин, хлоралгидрат.

Rp. Chlorali hydrati 10,0  
Spiritus Vini 70% 200,0  
MDS. По 3 столовых ложки в день

Умиравшим больным для облегчения страданий назначают морфин. Применяется также лучистая терапия (радий и рентген). При желудочном свище, наложенном для питания, необходимо наблюдать за проходимостью трубки и периодически ее менять. Во избежание раздражения кожу вокруг трубки смазывать жиром.

**Рак прямой кишки (cancer recti).** К заболеванию предрасполагает застой каловых масс и раздражение ими прямо- кишки, а также геморрой, полипы. Рак дает метастазы в лимфатические узлы малого таза и паховой области, прорастает мочевой пузырь, простату, мочеиспускательный канал, влагалище, матку. В запущенных случаях метастазы бывают в печень, легкие и кости (по кровеносным сосудам) и другие органы.

**Симптомы и течение.** Растущая опухоль вызывает катарр кишки (выделяется слизь, скопление которой ведет к частым позывам на низ). Мучительные тенезмы с выделением крови, гноя (важный признак) и обрывков распавшейся ткани. Гнойные выделения постепенно становятся зловонными. Затруднение акта дефекации; иногда — непроходимость кишок. Жалобы на тяжесть в животе, вздутие в нижней половине живота. Запоры чередуются с поносами. Больные со временем начинают жаловаться на "расстройство самочувствия, слабость, быстрое утомление, теряют сон, аппетит, бледнеют, теряют в весе; развивается кахексия; вследствие потери крови развивается анемия. Метастазы осложняют состояние больных.

**Распознавание.** Учитывать возраст: кровотечение из прямой кишки в пожилом возрасте подозрительно на рак; исхудание подтверждает подозрение. При исследовании пальцем прощупывается опухоль в виде плотного образования. Исследовать прямую кишку ректоскопом и взять для исследования кусочек опухоли. Необходимо дифференцировать от плотных тромбированных вен при геморрое и внутренних геморроидальных узлов, туберкулеза, сифилиса.

**Лечение оперативное.** При невозможности — рентгено- и радиотерапия; при полной непроходимости — наложение искусственного заднего прохода.

Рак языка (cancer linguae). Развивается при длительном механическом и химическом раздражении, нередко — на почве лейкоплакии. По строению — чаще плоскоклеточный ороговевающий рак.

**Симптомы и течение.** Начинается с появления на языке язвы с плотными краями, с склонностью к кровотечениям. Гнилое отделяемое. Резкие боли. Рак переходит на дно рта, нижнюю челюсть, миндалины, слизистую щеки. Глотание и речь затруднены. Метастазы в подчелюстные железы, подбородочные и вдоль яремной вены, возможно и в надключичные.

Рак располагается на "боковой или ниже-боковой поверхности языка в виде плотного, довольно болезненного при надавливании припухания, которое быстро изъязвляется. Края язвы вывороченные. На шее и под челюстью рано прощупываются плотные лимфатические узлы. Сильное зловоние изо рта, слюнотечение. Боли, кахексия.

**Лечение.** В ранней стадии хороший результат дает оперативное вмешательство, лечение радием или его эманацией. Уход за ртом, особенно перед операцией, полоскание антисептическими растворами или теплым солевым или борным раствором; удаление кариозных зубов, прижигание язвы 20% карболовой или хромовой кислотой.

**РАНЫ (VULNERA).** Свежая инфицированная **рана**. Раны бывают резаные, ушибленные, рваные, колотые, огнестрельные<sup>^</sup>. Подлежат обычно оперативному лечению (первичной хирургической обработке). Последняя производится хирургом и может состоять в рассечении раны с частичным иссечением нежизнеспособных тканей, с остановкой кровотечения и удалением инородных тел

Наиболее целесообразна первичная обработка раны в течение первых часов после ранения, пока явления инфекции в ране **еще** мало выражены.

Важно поместить раненых в обстановку, допускающую оперативное лечение (в больницу) в первые часы после ранения (**чем** раньше, тем лучше).

Наиболее широкое распространение получила в Великую Отечественную войну первичная обработка раны, состоящая в ее рассечении и удалении нежизнеспособных тканей, загрязнений, кусков одежды и в остановке кровотечения с последующим обильным припудриванием раны и ее отдельных карманов порошком стрептоцида, сульфазола или какого-либо другого сульфаниламидного препарата. Вместо порошка в рану может быть введен один из сульфаниламидных препаратов в геле эмульсии.

Применение сульфаниамидов позволяет производить обработку и в более поздние сроки (через 12—24 часа после ранения). Еще большие возможности и лучшие результаты дает применение пеницилина как местно, так и внутримышечно в ближайшие дни после ранения.

**Доврачебная помощь.** Снимают или разрезают одежду раненого, сбивают вокруг места ранения волосы, смазывают края раны йодной настойкой. Небольшие раны смазывают йодной

настойкой по всей поверхности. Раны, загрязненные землей, обломками дерева и т. п., осторожно очищают, механически снимая грязь пинцетом или марлей.

**Остановка кровотечения.** Кровотечение в ране должно быть остановлено путем захватывания сосуда кровоостанавливающим зажимом и перевязки его, если можно это сделать без расширения раны. В прочих случаях накладывается давящая повязка, а при артериальном кровотечении из крупной артерии — жгут и больной срочно доставляется к врачу.

**Защита от инфекции.** Применяется перевязочный пакет первой помощи (индивидуальный пакет). При отсутствии стерильного перевязочного материала можно простерилизовать марлю кипячением в 1% растворе карболовой кислоты с последующим отжиманием продезинфицированными руками (мыть с мылом горячей водой с последующей обработкой спиртом или смазыванием концов пальцев йодной настойкой) или прокипяченными инструментами. Если никакого перевязочного материала нет, берут чистый платок, полотенце или салфетку (лучше свежесглаженные горячим утюгом).

**1. Открытый способ лечения.** Использование бактерицидного действия света, а также высушивающее и окисляющее влияние воздуха. Раневая поверхность должна находиться в таком положении, чтобы был обеспечен наилучший отток<sup>\*</sup> отделяемого раны. Для защиты от мух, инфекции из воздуха и с окружающих предметов над раной устанавливают особые "сетки, муфты, колпачки, ватно-марлевые и лигнинно-марлевые кольца, прикрепляющиеся к коже клеолом. Края раны смазывают вазелином, насыщающие кругом раны корочки удаляют пинцетами. Допускается светолечение раны (солнце, лампа<sup>\*</sup> соллюкс).

**2. Асептическая повязка.** Наложенная на рану марля и повязка быстро пропитываются гноем и перестают всасывать. Поэтому приходится часто менять повязку, что является нежелательным.

Дренирование раны позволяет делать более редкие перевязки. К недостаткам дренажей относится возможность образования пролежня на стенке сосуда при длительном пребывании дренажа в ране. Еще более редкие (через 2—3 недели) перевязки делают после наложения гипсовой повязки на рану конечностей. Благодаря гигроскопичности гипса гной всасывается и испаряется с поверхности повязки.

**3. Повязка из гипертонического раствора** (10% раствор поваренной соли). Вызывает усиленную лимфатическую секрецию, благодаря чему из раны удаляются токсины, омертвевшие ткани быстрее отторгаются и развиваются нормальные грануляции.

**4. Антисептическая повязка.** Делается из материала, пропитанного антисептическим раствором; применяется с целью воздействия на инфекцию и чтобы избежать развития в ране личинок мух при редкой смене повязок. Пользуются марганцово-кислым калием (1 : 1 000), риванолом (1% : 500), хлорамином (1%), стрептоцидом (5,0—10,0).



**5. Мазевые повязки.** Для лечения ран пользуются мазевой повязкой, предложенной Вишневским. Rp 01. Cadini. s. Picis liquidae 3,0 T-rae Jodi (10%) 1,0 01. Ricini 100,0 Mf. ung. DS. Мазь Вишневского

**Гнойная рана.** Реакция организма на инфекцию в ране выявляется симптомами воспаления.

**Лечение** в первом периоде (фазе гидратации): покой, повышение экссудации и лейкоцитоза, активная гиперемия, воздействие на микробов, гипертонические растворы, антисептика, мазь Вишневского.

Во втором периоде (фазе регенерации) при очищенной от продуктов распада ране и образовании раневого барьера — защита грануляций от повреждений и вторичной инфекции (повязка с рыбьим жиром, вазелином, открытое лечение).

**Средства общего воздействия** имеют целью влиять на сердечно-сосудистую систему, паренхиматозные органы, водно-солевой, углеводный и белковый обмен: вакцины и сыворотки повышают иммунобиологические свойства организма; внутримышечное применение пенициллина и прием сульфаниламидных препаратов внутрь воздействуют на инфекцию.

**РАНЕВОЕ ИСТОЩЕНИЕ.** Осложнение длительно протекающего раневого процесса; причины: длительная лихорадка, всасывание продуктов распада, хронически протекающая септическая инфекция, потеря с гноем большого количества белков и липоидов. К развитию истощения особенно склонны больные с ранением эпифизов костей, суставов и грудной полости.

**Симптомы.** Температура длительное время, потеря аппетита, нарастающее исхудание и падение гемоглобина, нередко поносы; вялый вид грануляций раны со слабой склонностью к заживлению, водянистые или легко кровоточащие грануляции, образование затеков гноя.

**Лечение.** Оперативное раскрытие затеков. Борьба с инфекцией (пенициллин, сульфаниламиды), усиленное питание (но не переходить на строгую диету и при поносах), повторное переливание крови.

**РАНЕНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.** При закрытых повреждениях брюшной стенки наблюдают кровоизлияния. Кровоизлияния в подбрюшинную клетчатку могут быть в первое время незначительными, а затем появляются в виде отдельных кровоизлияний на передней поверхности бедра, мошонке и т. п. (гематомы, кровоподтеки). При открытых повреждениях могут быть ранены только мягкие ткани до брюшины (непроникающие ранения) или повреждена брюшина и брюшные органы (проникающие ранения).

**Симптомы и течение.** Жалобы на боль в месте повреждения или по всему животу. При проникающих ранениях на первый план выступают явления шока: брюшная стенка напряжена частично или по всему животу, дыхание грудное; невозможность

мочиться и испражняться; симптомы внутреннего кровотечения или раздражения брюшины. При внутреннем кровотечении — нарастающее малокровие, падение пульса. При ранении кишок и желудка — резкое напряжение брюшных стенок, не проходящее при покойном положении, давление на живот вызывает резкую боль; в большинстве случаев рвота (при ранении желудка кровавая).

При ранениях печени и селезенки основным симптомом — внутреннее кровотечение и увеличение тупости печени и селезенки с расширением в подвздошную область; кроме того, при ранениях печени жалобы на боль в области печени с отдачей в правое плечо, а при ранениях селезенки — на боль в области левого подреберья и в левом плече.

Открытые повреждения и огнестрельные ранения нередко осложняются гнойным воспалением брюшины (перитонитом), развивающимся в результате внесения в брюшную полость инфекции с ранящего оружия или при ранении кишок и желудка.

**Распознавание.** При ранениях внутренних органов распознаванию помогают явления внутреннего кровотечения. При проникающих ранениях живота диагноз облегчает выпавший в рану сальник или кишка и истечение из раны желчи или кишечного содержимого.

**Лечение.** При ушибах живота — постельное содержание, холод в первые дни. Введение наркотиков противопоказано. Борьба с шоком: согревание больного, сердечные возбуждающие, введение под кожу 5% раствора глюкозы 250—300 мл, переливание крови — 500—600 мл. При проникающих ранениях с ранением или без ранения органов брюшной полости — немедленная операция. Выпавшую кишку или сальник не следует вправлять в брюшную полость до операции; кожу вокруг раны смазать настойкой йода и наложить асептическую повязку и направить больного в больницу для немедленной операции. Подкожное введение противостолбнячной сыворотки, пенициллина.

**РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ.** Могут быть ранены только мягкие ткани грудной клетки или также внутренние органы. Ранения с повреждением плевры и легких относят к проникающим. Они могут быть нанесены ножом, кинжалом, штыком, ружейными и револьверными пулями, осколками снарядов.

**Симптомы и течение.** При проникающих ранениях грудной клетки развивается шок и образуется открытый пневмоторакс с затруднением дыхания. Из раны легкого может быть кровотечение. При ранении плевры полость ее может инфицироваться с образованием эмпиемы. При огнестрельных ранениях легкого — кровохарканье (кровь с примесью пузырьков воздуха). В тяжелых случаях развивается шок: кожные покровы бледнеют, конечности холодеют, губы синеют, появляется одышка. Пульс малый, одна ощутимый, неправильный. Могут развиваться явления пневмоторакса или гемоторакса, на что указывает одышка, цианоз. Пульс становится малым, частым. Если температура повышается, появляется проливной пот, то это указывает на переход гемоторакса в пиоторакс.

**Лечение.** Борьба с шоком: ваго-симпатическая блокада по Вишневскому, закрытие пневмоторакса окклюзионной повязкой,

состоящей из пластинки резины от стерильной резиновой перчатки, прикрывающей рану, или полосок липкого пластыря. При колото-резаных ранах и при открытом пневмотораксе — первичная обработка. Нарастающие признаки внутреннего кровотечения требуют оперативного вмешательства. При осложнении эмпиемой — операция (торакотомия).

При сквозных огнестрельных ранениях с небольшим входным и выходным отверстием, а также при слепых огнестрельных ранениях без нарастающего кровотечения или пневмоторакса надо лишь смазать кожу вокруг отверстий и наложить коллоидную повязку. При прогрессирующем пневмотораксе — клапанный дренаж. При гемотораксе — прокол для удаления крови. При открытом пневмотораксе с большой раной, проникающей в грудную полость, — тампонада с последующим оперативным лечением.

Окончательную обработку раны легкого и перевязку кровоточащего сосуда производят в больнице.

**РАНЕНИЯ ЧЕРЕПА И МОЗГА.** В первые часы после ранения развивается травматический отек мозга с последующим повышением внутричерепного давления.

Различают непроникающие и проникающие ранения. К первым относятся ранения без повреждения твердой мозговой оболочки. Огнестрельные ранения делят на: 1) сегментальные, 2) диаметральные, 3) диагональные и 4) слепые.

**Симптомы и течение.** Зависят от местоположения, распространенности и тяжести повреждения. При огнестрельных ранениях наблюдаются явления сотрясения, сдавления, ушиба мозга (см. *Мозга повреждения*).

**Лечение.** Первичная обработка. Первая помощь состоит в борьбе с шоком, покое, согревании, введении гипертонических растворов.

**РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК СУСТАВОВ (DISTORSIO).** Наступает при резком грубом движении в суставе, переходящем физиологические пределы.

**Симптомы и течение.** Боль и припухлость в области сустава; сохраняющего в общем нормальные очертания при правильном взаимоотношении суставных концов. Движения в суставе возможны, но болезненны и ограничены. Больной может отчасти пользоваться поврежденной конечностью, например, наступает на ногу, двигает больной рукой.

**Лечение.** Покой для пострадавшего сустава. При растяжении связок на ноге больного укладывают в постель с приподнятой ногой, при растяжении связок на руке подвешивают руку на перевязь. В тяжелых случаях разрывов связок — гипсовая повязка.

К месту повреждения для уменьшения кровоизлияния и болей назначают холод (пузырь со льдом, холодные компрессы). Со вторых суток назначают тепловые процедуры (согревающий компресс, ванны) и массаж. Поврежденный сустав долго остается предрасположенным к повторению растяжения, и его надо тщательно оберегать.

**САРКОМА (SARCOMA).** Злокачественная соединительнотканная опухоль, развивающаяся из фасций, мышечных влагалищ,

надкостницы. Этиология неизвестна. Поражается преимущественно молодой возраст. Дает метастазы по току крови (прежде всего в легкие и по лимфатической системе).

**Симптомы.** Быстро растущая, прорастающая окружающие ткани плотная опухоль; рано развивается кахексия; иногда сильные боли.

**Лечение.** Ранняя радикальная операция, иногда ампутация конечности.

**СВИЩИ (FISTULAE).** Могут быть результатом воспалительного процесса, случайного ранения или быть сознательно наложены во время операций (например, мочевого свища для отведения мочи).

Свищи гнойные. Ведут в полость, образовавшуюся вокруг инородного тела, например, пули, осколка снаряда, лигатур и швов при их инфекции (при нагноении раны) или являются результатом воспалительного процесса в кости или суставе (туберкулез, остеомиелит).

**Лечение.** Необходимо удалить инородное тело (пулю, лигатуру и т. д.). В качестве временной меры — повязки с достаточным количеством всасывающего материала и защита кожи кругом свища от раздражения гноем (смазывание пастой).

Свищи желудочные. Чаще всего накладываются оперативным путем. Если имеется подтекание желудочного содержимого вокруг трубки, то кожа раздражается и нередко возникает экзема.

**Лечение.** Оперативное закрытие. При невозможности — частые перевязки и смазывание пастой кожи вокруг дренажа.

Свищи желчные. Истечение желчи в рану чаще всего наблюдается после операции на желчных ходах.

**Лечение** оперативное. Для защиты кожи от раздражения желчью необходимо чаще перевязывать и смазывать кожу пастой, а рану туго тампонировать.

Свищи заднего прохода. Остаются после парапроктических гнойников, вскрывающихся в прямую кишку и около заднего прохода.

**Симптомы и течение.** Ход свищей извилист. Вокруг свища образуется плотный рубец. Существование свища поддерживается постоянным загрязнением инфекционным материалом и неполным его опорожнением. У отверстия свища на коже бывает небольшой грануляционный бугорок и корочка. При полных свищах одно отверстие открывается в кишку, другое — наружу; при неполных — отверстие одно (в кишке или на коже).

**Лечение** оперативное.

Свищи каловые. Возникают на "почве" повреждения кишки или ее ущемления и накладываются искусственно для выведения кишечного содержимого. Через каловый свищ могут выходить у больного газы и каловые массы частично или полностью.

**Лечение** оперативное. При перевязках нужно тщательно защищать окружающую свищ кожу от возможного раздражения и появления экземы. Кожу у окружности свища смазывают пастой, мазями (цинковой, висмутовой, мазью Вишневского, жиром) или раствором марганцовокислого калия.

Свищи мочевые (мочеточниковые, мочевого канала, пузырьные). Пузырные свищи нередко накладываются оперативно при различ-

ных заболеваний мочевого пузыря и канала для постоянного или временного отведения мочи; в отверстие свища вводят дренажную трубку, через которую моча отводится в бутылку (сифонный дренаж)."

**Лечение** см. *Каловые свищи*.

Свищи слюнные. Обычно результат ранения слюнной железы или ее протока. Выделяющаяся слюна (особенно во время еды) раздражает кожу.

**Лечение** оперативное. Для уменьшения отделения слюны больному дают жидкую пищу, нежирное питье и атропин внутрь или под кожу.

Свищи и кисты шеи. Чаще встречаются врожденные свищи и кисты шеи.

**Симптомы и течение.** Срединные кисты шеи в виде небольших опухолей развиваются на передней поверхности шеи по средней линии — от подъязычной кости и ниже; иногда они нагнаиваются и вскрываются, образуя незаживающий свищ; из свища отделяется серозная или гнойно-слизистая жидкость; кожа вокруг свища воспалительно изменена и иногда рубцово перерождена. Боковые кисты и свищи шеи располагаются спереди края грудино-ключично-сосковой мышцы, из них выделяется слизистая жидкость; свищевой ход направляется к боковой стенке глотки.

**Лечение** оперативное.

**СДАВЛЕНИЕ МОЗГА** см. *Мозга повреждение*.

**СЕПСИС ХИРУРГИЧЕСКИЙ. СЕПТИЦЕМИЯ (SEPTICAEMIA). СЕПТИКОПИЕМИЯ (SEPTICOPYAEMIA).** Вызывается чаще стафилококком, реже стрептококком, диплококком или смешанной инфекцией. Общая гнойная инфекция может наступить после предварительного развития лимфангоита, тромбоза, но может развиться и непосредственно за местным гнойным заболеванием и даже без ясного местного очага. Общая гнойная инфекция бывает с метастазами и без метастазов.

**Симптомы и течение.** Высокая температура со значительными колебаниями или без них; быстро нарастающая интоксикация, учащение пульса, наклонность к кровотечениям, проливные поты, изменения крови (сдвиг белой крови влево) и т. д. Отмечается вялость заживления в гнойном очаге, недостаточность отделяемого (сухие раны), прогрессирующее гнойное расплавление тканей или геморрагическое отделяемое; истощение больного.

**Лечение.** Полный покой местного гнойного очага при хорошем вскрытии и дренировании его. Новые очаги подлежат немедленному вскрытию. Наибольшее значение имеет применение сульфаниламидных препаратов, пеницилина и стрептомицина, особенно в комбинации.

Для уменьшения интоксикации вводятся значительные количества жидкости (до 3—5 л за сутки) в виде капельных внутривенных или подкожных вливаний; производится переливание крови и ВНС.

При гнойном процессе, вызываемом стрептококками, вводится ежедневно также поливалентная антистрептококковая, а при гемолитическом стрептококке — противоскарлатинозная сыворотка по 50,0—100,0 в день в течение нескольких дней. При процессах ста-

филококкового происхождения, протекающих вяло, — вакцина от ОД до 1,0 через 1—2 дня. Иногда применяют внутривенное вливание уротропина.

Rp. Sol. Urotropini 40% 10,0  
Sterilisetur! DS. По 5—10 мл  
в вену

**СКОЛИОЗ (SCOLIOSIS).** Искривление позвоночника по фронтальной плоскости. Сколиоз может быть левосторонним, когда вогнутость обращена влево, и правосторонним, когда вогнутость обращена вправо.

По этиологическим моментам отмечают несколько видов сколиозов. Врожденный сколиоз зависит от врожденной клиновидной формы одного или нескольких позвонков.

Рахитический сколиоз — наиболее часто встречающаяся форма и развивается рано — на первом году жизни у детей, больных рахитом, под влиянием длительного сидения. Для исправления сколиоза ребенка укладывают в гипсовую кроватку. Привычный сколиоз развивается в силу привычки сидеть или стоять в согнутом в ту или другую сторону положении. Статический сколиоз является вторичным сколиозом и зависит от неодинаковой длины ног; наблюдается при врожденном вывихе бедра, при укорочении конечностей и т. д.

Паралитический сколиоз наблюдается при одностороннем параличе спинных мышц.

Рубцовый, или плевритический сколиоз развивается после перенесенного гнойного плеврита.

Лучшим средством лечения сколиозов является специальная лечебная гимнастика.

**СЛОНОВОСТЬ (ELEPHANTIASIS).** Выражается в гиперплазии кожи и подкожной клетчатки. Чаще всего поражаются нижние конечности. Имеет значение застой лимфы с резким расширением лимфатических сосудов и щелей и одновременно гипертрофией и гиперплазией соединительнотканых элементов кожи.

**Симптомы и течение.** Конечность сильно обезображивается. Кожа утолщена. Местами на стиге образуются складки, местами кожа мацерируется, покрывается корками. В некоторых случаях образуются обширные экзематозные поверхности. В далеко зашедших случаях нарушается функция конечности.

**Лечение.** В начальных стадиях — покой, высокое положение конечности, тугое бинтование, горячие и суховоздушные ванны.

Поражения кожи лечат индифферентными мазями.

**СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА** см. *Мозга сдавление*.

**СПОНДИЛОЛИСТЕЗ.** Соскальзывание вышележащего позвонка с нижележащего. Так, например, может соскользнуть V поясничный позвонок с I крестцового. Смещение происходит вниз и вперед. Дужки и остистый отросток остаются на месте. Больные жалуются на боль в пояснице, которая усиливается при стоянии. Боль иногда отдает в конечности. Диагноз ставится после рентгенографии.

**Лечение.** Ортопедическое и оперативное.

**СТОПА КОНСКАЯ.** Конской стопой называют контрактуру голеностопного сустава в положении подошвенного сгибания. Развивается вследствие паралича разгибателей или при спастическом состоянии сгибателей, а также при длительной иммобилизации стопы в неправильном положении в гипсовой повязке, после продолжительного пребывания в положении подошвенного сгибания под тяжестью одеяла у тяжело больных или же после длительного хождения на костылях со свешенной ногой. При ходьбе больной опирается на головки плюсневых костей или на тыльную поверхность стопы.

**Лечение.** Исправляют порочное положение повязками и оперативным путем.

**СТОПА ПЛОСКАЯ (PES PLANUS).** Врожденная плоская стопа развивается в результате неправильного положения стопы в матке, давления стенок последней и наблюдается в комбинации с другими уродствами. Приобретенная плоская стопа — вследствие рахитического поражения кости в раннем детстве или в период половой зрелости и усиленного роста. Имеет значение слабость мышц и связочного аппарата при длительной нагрузке на стопу (профессиональная).

**Распознавание.** Степень плоскостопия определяется получением отпечатков на бумаге. При высокой степени плоскостопия отпечатывается вся подошва.

**Симптомы.** Стаптывание наружного края каблука. Быстрая утомляемость при ходьбе, уплощение стопы при стоянии, боли в ноге.

**Лечение.** Для предупреждения развития плоской стопы — ношение в детстве хорошо пригнанной обуви. При наличии плоской стопы у взрослых — ортопедическая обувь и супинаторы.

**СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА (STRICTURA OESOPHAGI).** Причины: ожоги (особенно часто щелочью), травмы и воспалительные заболевания.

**Симптомы и течение.** Нарастающее расстройство глотания (дисфагия): сначала с трудом проходят куски объемистой и плохо разжеванной пищи, затем кашцеобразная и, наконец, жидкая пища; при полном закрытии просвета не проходит даже вода. Больной страдает от неудовлетворенного голода и жажды, истощается, обезвоживается. Процесс имеет склонность к про-грессированию. Раздражение пищей вызывает воспалительные явления и отек слизистой, ухудшающие проходимость, и ведет к спастическим сокращениям мышц пищевода.

**Лечение.** Вужирование при сужении после ожогов. Против спастического сокращения — атропин.

Rp. T-rae Belladonnae 15,0

DS. По 15 капель 3 раза в сутки за 15 минут до еды

При значительном сужении, не поддающемся бужированию, операция наложения желудочного свища с последующим бужированием; при полном прекращении прохождения пищи — создание искусственного пищевода.

### III

**СУЖЕНИЕ УРЕТРЫ (STRICTURAE URETHRAE).** Вызывается развитием рубцовых тканей после повреждения (ранений) уретры и после гонорройных уретритов. Оно проявляется иногда спустя много лет после перенесенной гонорреи или через несколько месяцев после травмы.

**Симптомы и течение.** Утончение струи мочи, более длительное мочеиспускание. Стенка пузыря, вследствие гипертрофии мышц, вначале больной справляется с появившимся затруднением опорожнения, а затем струя становится вялой, больной мочится в несколько приемов, пузырь полностью перестает опорожняться и моча начинает выделяться по каплям. Наконец, может наступить полная задержка мочи. Развивающийся воспалительный процесс дает периретральные абсцессы, мочевые затеки и мочевые свищи.

**Лечение** проводится при помощи бужирования или оперативным путем. Во избежание возможных рецидивов больные должны систематически проверяться (пробное проведение бужа) в течение многих лет.

**СУСТАВ БОЛТАЮЩИЙСЯ.** Появляется при вялых параличах, вследствие податливости связочного аппарата, и при невропатических деформациях суставов (сухотка спинного мозга, сирингомиелия).

**Симптомы и течение.** Избыточная подвижность в суставе, легко приводящая к подвывиху или вывиху и затрудняющая пользование конечностью.

**Лечение** ортопедическое: шинно-гильзовые аппараты для предупреждения вывихов и облегчения пользования конечностью. В некоторых случаях операция образования искусственного -анкилоза в суставе.

**СУСТАВА ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ (ARTHRITIS PURULENTA).** Гнойная инфекция попадает в сустав при ранении с соседних тканей и с током крови при общем гнойном заражении. Обычно заболевание начинается очень бурно и остро, являясь одним из самых тяжелых гнойных процессов. Гнойное воспаление ограничивается только синовиальной оболочкой (гнойный артрит) или захватывает, кроме капсулы, еще и другие части сустава и сопровождается разрушением суставных хрящей и флегмонозным поражением окружающих сустав тканей (капсулярная флегмона).

**Симптомы и течение.** Заболевание обычно начинается резкими болями в суставе, из-за которых движения становятся совершенно невозможными. Объем сустава увеличивается, и даже легкое прикосновение к нему вызывает боли. Общее состояние больного очень тяжелое, температура повышается иногда до 40°, появляется озноб, кожа области пораженного сустава горяча на ощупь, иногда воспаленная, покрасневшая. Разрушение связочного аппарата и суставных хрящей и распад капсулы могут повести к резкому изменению формы сустава и патологическому вывиху.

**Лечение.** Лучше всего применять хирургическое лечение (повторные проколы, введение в полость сустава раствора пеницилина или широкое раскрытие сустава, обычно с последующим введением дренажей). Суставу следует придать неподвижное положение шинными повязками, иногда вытяжением, чаще же неподвижными гип-

совыми повязками. Одновременно — сульфаниламидные препараты, пенициллин. В случаях, когда и после разреза процесс не останавливается и состояние больного ухудшается, для спасения его жизни может быть произведена ампутация больной конечности.

**О с л о ж н е н и я .** Последствиями воспаления сустава даже при благополучном окончании процесса могут быть сращения между суставными концами. Они могут быть соединительнотканного и даже костного характера и вызывают неподвижность (анкилоз) сустава. Подвижность может быть резко ограничена вследствие сморщивания суставной сумки и окружающих мягких тканей, причем сустав нередко нельзя вывести из согнутого положения (контрактура сустава). Во избежание в дальнейшем малой функциональной пригодности конечности при воспалительных процессах в суставах нужно устанавливать ее так, чтобы при неподвижности в суставе или плохой подвижности в нем конечность была пригодна для работы. С этой целью ногу слегка сгибают в тазобедренном суставе и отводят, коленный сустав выпрямляют, стопу ставят под прямым углом; в лучезапястном суставе ставят кисть в положение с ладонью, обращенной к туловищу при небольшом тыльном сгибании.

#### СУСТАВА СЕРОЗНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ (ARTHRITIS SEROSA).

Развивается иногда под влиянием острого воспалительного процесса вблизи сустава и как осложнение различных инфекционных болезней.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Лихорадочное состояние, боли, затрудненные движения в суставе. Сумка сустава сильно растягивается скопившейся в ней жидкостью, объем сустава увеличивается, формы и очертания изменяются (выпячиваются завороты суставной сумки); нередко в суставе чувствуется зыбление. Конечность при этом занимает обычно то положение, при котором емкость суставной полости наибольшая (обычно это положение неполного сгибания в суставе).

**Л е ч е н и е .** Покойное положение, местно применяют тепло, иногда давящие повязки.

**СУСТАВНАЯ МЫШЬ (MUS ARTICULORUM).** Части хряща или кости при травме или ворсинки суставной сумки при воспалении появляются в полости сустава в виде свободных инородных тел.

Симптомы. Если суставная мышца находится в каком-либо завороте сустава и не перемещается, она никаких симптомов не дает.

При перемещениях суставной мышцы возможно ущемление ее между суставными поверхностями. Тотчас появляются резкие боли и невозможность движений в суставе. В дальнейшем острые боли несколько стихают, появляется выпот в суставе (серозный артрит).

При перемене положения в суставе мышца выскальзывает из ущемления и болевые ощущения прекращаются. Такие ущемления происходят иногда очень часто и лишают больного трудоспособности. Более точный диагноз дает рентгенологическое исследование: костная суставная мышь видна на снимке в виде округлой тени.

**Л е ч е н и е .** Оперативное удаление. И

**ТЕНДОВАГИНИТ ГНОЙНЫЙ (TENDOVAGINITIS PURULENTA).** Возбудители — чаще всего стрептококки и стафилококки. Наибольшее значение имеет тендовагинит сгибателей пальцев. Инфекция

попадает при повреждении влагалища (наколы), при гнойных процессах кисти и пальцев (особенно часто I и V пальца). Воспалительный выпот во влагалище дает сдавление и тромбоз питающих сухожилие сосудов и некроз сухожилий. Нередко флегмонозный процесс переходит на предплечье и развивается сепсис.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Высокая температура, тяжелое общее состояние; жестокие боли и резкое ограничение движений пальцев, припухлость в нижней части предплечья, отек клетчатки тыла кисти. Процесс распространяется на окружающие мягкие ткани. При позднем или самостоятельном вскрытии гноя наблюдаются длительно не заживающие свищи вследствие некроза сухожилий.

**Л е ч е н и е .** Покой, иммобилизация, введение пеницилина в сухожильное влагалище, возможно быстрое вскрытие для предупреждения некроза сухожилий, небольшие множественные разрезы по сторонам сухожилий, ванны, по окончании острых явлений — ранние движения (функциональное лечение). Сульфаниламидные препараты внутрь.

**ТЕНДОВАГИНИТ КРЕПИТИРУЮЩИЙ (TENDOVAGINITIS CREPITANS).** Наблюдается у лиц физического труда, после длительных быстрых и однообразных или непривычных движений (на руках слесарей, прачек, пианистов, на ногах после больших переходов). Чаще поражаются сухожильные влагалища разгибательной поверхности предплечья, голени, пальцев, кисти, стопы и ахиллова сухожилия. Появляется серозно-геморрагический или фибриновый выпот в окружности влагалища или в нем самом.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Болезненность при движениях какой-либо мышцы или группы мышц, припухлость по ходу сухожильного влагалища. При движениях ощущение хруста (крепитации). Воспаление развивается остро и проходит при лечении в 10—15 дней; имеет склонность рецидивировать и переходить в хроническую форму с периодическими обострениями.

**Л е ч е н и е .** Покой, шинная повязка, в дальнейшем теплые ванны (грелки, физиотерапевтическое лечение, тугое бинтование). Внутрь аспирин по 0,3 три раза в день, пирамидон по 0,3 три раза в день, на пораженную область мази.

Rp. Methyl salicylic  
Chloroformii  
01. Hyoscyami aa 10,0  
MDS. Наружное.

Возобновление работы через 6—7 дней после исчезновения припухлости и крепитации.

**ТРАВМАТИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ.** Под травматической асфиксией подразумевают своеобразную клиническую картину, наблюдающуюся после сильного сдавления грудной клетки между буферами вагонов, при обвалах в окопах. Кожа головы и шеи становится темносиней, отечной, с мельчайшими точечными кровоизлияниями и кровоподтеками. Точечные кровоизлияния находят в слизистой рта, в глазу. Иногда, вследствие инфильтрации клетчатки кровью, наблюдается экзофтальм.

При травматической асфиксии скелет грудной клетки повреждается редко.

Без повреждения органов все эти явления проходят через несколько дней.

**ТРЕЩИНЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА (FISSURE ANI).** Ссадила или поверхностная рана, расположенная перпендикулярно ходу волокон сфинктера. Образуется под влиянием травмы во время дефекации или родов. Помещается обычно на уровне сфинктера у заднего края заднепроходного отверстия по средней линии или вблизи нее.

**Симптомы и течение.** Боль при испражнении часто в течение нескольких часов.

**Лечение.** Регулирование стула (он должен быть мягким). Против болей — свеча с белладонной или морфином. Хорошо действуют теплые ванны. Смазывание трещин 5% раствором кокаина или 2% раствором дикаина, или концентрированным раствором марганцовокислого калия. Прижигают также ляписом после предварительного растягивания сфинктера под наркозом или местной анестезией.

**ТРОМБОФЛЕБИТ (TROMBOPHLEBITIS).** Воспаление вен главным образом инфекционного происхождения.

**Симптомы и течение.** Болезненность по ходу вен. При развитии тромбофлебита в поверхностных венах они прощупываются в виде плотных тяжей, болезненных наощупь; при поражении глубоких вен — отечность конечности, синюшность кожи и расстройства кровообращения. Нередко гнойное расплавление тромбов и образование гнойников по ходу сосуда.

**Лечение.** Полный покой больной части тела: лежание, шинные повязки. Больную часть тела кладут в приподнятом положении для улучшения оттока крови. В покойном лежачем положении больной должен находиться до полного затихания процесса. Запрещаются всякого рода растирания и массаж. Они могут вызвать распространение гнойного процесса на весь организм и путем переноса оторвавшегося сгустка привести к закупорке артерий мозга или сердца, что нередко ведет к немедленной смерти больного (эмболия). Местно повторное применение пиявок (4—5). Одновременно сульфаниламидные препараты и пенициллин, дикмарол. Нельзя делать внутримышечных инъекций в пораженные конечности; не следует производить внутривенных вливаний.

**ТУБЕРКУЛЕЗ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (ЖЕЛЕЗ) (LYMPHADENITIS TUBERCULOSA).** Попадая в лимфатические пути, туберкулезная инфекция нередко задерживается в ближайших лимфатических узлах (корня легкого, забрюшинные, шейные). Поражение желез составляет около  $\frac{1}{3}$  случаев хирургического туберкулеза, причем 90% заболеваний падает на шейные узлы. При распаде и расплавлении туберкулезных фокусов образуются абсцессы и свищи. Возможен и другой исход — рубцевание и обызвествление очага.

**Симптомы и течение.** Течение лимфаденитов хроническое; общее состояние больного изменяется мало, температура слегка повышена или нормальна. Прощупываются пакеты плотных,

\*)

спаянных между собой узлов, в окружности мелкие, как горох, узлы. В дальнейшем образуются свищи.

**Лечение.** Общее лечение туберкулеза. Местная рентгенотерапия и облучение кварцевой лампой. При распаде узлов, отсасывание содержимого и введение стрептомицина, при присоединении гнойной инфекции, когда образуется гнойник, прибегают к его вскрытию.

Rp. Streptomycini 300 000 единиц

DS. Для введения внутримышечно или в  
очаг поражения в 2 мл 0,5% раствора  
новокаина

**ТУБЕРКУЛЕЗ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ (TUBERCULOSIS OS-SIUM).** Поражение костей и суставов вторичное; чаще поражается позвоночник, коленный, тазобедренный сустав, реже все другие суставы. Процесс начинается чаще с суставного конца костей, но иногда и с синовиальной оболочки. Сустав вовлекается в процесс вторично. Образуется серозный или серозно-фибринозный выпот, иногда с разрастанием грануляционной ткани или с распадом, ведущим к скоплению в суставе гноя с последующим прорывом его наружу и образованием свищей.

**Симптомы и течение.** Постепенное начало с неясными признаками. В дальнейшем появляются боли и атрофия мышц. Боли усиливаются при движениях и нагрузке на больную часть тела, при давлении и поколачивании. Некоторая утомляемость, затем полная невозможность пользоваться больной конечностью, вследствие болезненности движений, мышечных спазмов, а в более поздние периоды — от изменений связочного аппарата и разрушений суставных концов. В суставе появляется плотная или мягкая опухоль. На рентгеновском снимке резкая атрофия кости. Длительность неосложненных случаев костно-суставного туберкулеза — несколько лет; в осложненных случаях заболевание принимает еще более длительный характер. Нередко наступает кажущееся выздоровление, продолжающееся ряд лет, с последующими новыми обострениями процесса.

**Лечение.** Значительная роль принадлежит общему и местному светолечению (кварцевая лампа, солнечные ванны). Местные и общие солнечные ванны применяются осторожно, с постепенным увеличением длительности облучения. Местное лечение: полный покой пораженного органа достигается неподвижными повязками или вытяжением. Лечение стрептомицином.

При наличии свищей — предохранительные перевязки во избежание занесения извне гноеродной инфекции. В свищи через тупые канюли вливают йодоформную эмульсию, расширяют их и раскрывают инфицированные затеки и околосуставные флегмоны. Большое значение имеет лечение натечных гнойников: отсасывание гноя пункцией (но не разрезом) с последующим впрыскиванием стрептомицина или йодоформной эмульсии. Укол производят с соблюдением всех правил асептики: сбоку, в стороне от вершины абсцесса.

Оперативное лечение — резекция очага или резекция сустава. При прогрессирующем процессе, а также у стариков, у которых обычно отсутствует склонность к заживлению процесса, приходится иногда применять ампутацию больной конечности.

**ТУБЕРКУЛЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА (GONITIS TUBERCULOSA).** Симптомы и течение. Незначительная вначале болезненность, увеличение объема сустава, выпот, дающий флюктуацию и ballotирование надколенника, ограничение подвижности, атрофия мышц. Сустав приобретает веретенообразный вид. Хрящи и кости разрушаются, нога в положении сгибания; образуются подвывихи, натечные абсцессы, свищи.

**Лечение** см. *Туберкулез костей и суставов*. Оперативное лечение применяется чаще, чем при поражении других суставов. Гипсовые повязки и длительная разгрузка конечности (хождение на костылях).

**ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЗВОНОЧНИКА (SPONDYLITIS TUBERCULOSA).** Наиболее часто встречается в детском возрасте (80%). Вызывает разрушение тела позвонка, образование натечника и изменение формы позвоночника (горб). Возможно сдавление спинного мозга.

**Симптомы и течение.** Боли вначале неопределенные и непостоянные, затем локализованные, усиливающиеся при движении, нагрузке и поколачивании по остистым отросткам; нередко иррадиация в брюшную стенку, в конечности. Спинные мышцы области поражения напряжены; так называемый «симптом вожжей», т. е. появление при поколачивании и движении мышечных тяжей, расходящихся под углом. Подвижность позвоночника ограничена, особенно сгибание вперед; больной опирается при этом рукой на ногу и сгибает коленные суставы, а не позвоночник. При разрушении позвонка остистый отросток выступает назад в виде остроугольного кифоза, развиваются натечники в заглоточном пространстве, средостении, надключичной, подключичной и подмышечной области (шейные позвонки), в области межреберных сосудов, брюшной аорты, бедренных артерий (грудные позвонки) или на 3-м, 4-м, 5-м позвонках, в тазовой и поясничной области (поясничные позвонки). При сдавлении спинного мозга параличи и расстройства чувствительности.

**Лечение** см. *Туберкулез костей и суставов*. Длительное лежание с вытяжением или в гипсовой кровати, при стихании процесса — палочное корсета.

**ТУБЕРКУЛЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА (COXITIS TUBERCULOSA).** Поражается чаще одна из костей, затем хрящ и сумка сустава. Разрушение хряща и кости приводит к деформации, развитию казеозного распада, скоплению гноя и его прорыву с образованием свищей.

**Симптомы и течение.** Утомление при ходьбе, боли при движениях, особенно резких (прыжки), ночные боли, уменьшение подвижности, деформация сустава, контрактура.

Различают три стадии: первая — болевые симптомы, увеличение объема сустава, сгибание, отведение и наружная ротация ноги (больной еще ходит); вторая — разрушение сустава, сгибание и приведение ноги (больной лежит); третья — дальнейшее раз-

рушение связок, атрофия мышц, патологические вывихи, натечники, укорочение конечности.

**Лечение** см. *Туберкулез костей и суставов*. Лежачее положение, вытяжение, а затем гипсовая повязка, неоднократно сменяемая. Нередко остается ограничение подвижности и анкилозы.

**ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЧКИ (TUBERCULOSIS RENIS).** Различают две клинические формы туберкулеза почки. Острая милиарная форма наблюдается при активном туберкулезном процессе. Эта форма туберкулеза почки является симптомом генерализации процесса. Оперативному лечению не подлежит.

Хронический туберкулез развивается в результате заноса туберкулезной палочки из существующего в организме туберкулезного очага. Течение процесса медленное. В начальной стадии в почке развиваются бугорки; позднее почка увеличивается в объеме и становится бугристой. В самой почке образуются полости (каверны), заполненные гноем или творожистыми массами. В результате туберкулеза развивается туберкулезный пионефроз.

**Симптомы.** Туберкулез почки протекает различно; в начале заболевания все жалобы больных можно свести к общей слабости, быстрой утомляемости и прогрессирующему исхуданию. • -

При исследовании мочи обнаруживается эритроциты и лейкоциты. Первым симптомом, иногда обращающим внимание самих больных, является наличие крови в моче, видимое простым глазом. Вообще же гематурия может быть определена микроскопически. Она может исчезать и сменяться пиурией. Больные иногда жалуются на коликообразного характера боли и учащенное мочеиспускание ночью. Расстройство мочеиспускания зависит от туберкулезного цистита, при котором емкость пузыря иногда значительно уменьшается. В моче единичные гиалиновые цилиндры, реакция кислая.

Для исследования и обнаружения туберкулезной палочки в моче берут суточную мочу и ищут палочку в центрифугате. При отрицательном результате производят посевы на специальные среды или проводят биологическую пробу — впрыскивают осадок морской свинке. Пораженную почку можно прощупать лишь у худых больных. В запущенных случаях прощупывается бугристая плотная подвижная болезненная опухоль. Симптом Пастернацкого выражен ясно. Таким образом, характерными симптомами являются: 1) бесцилиндровая альбуминурия; 2) пиурия асептическая или с наличием туберкулезных палочек; 3) цистит, не уступающий местному лечению.

Исследование\* больных начинается с исследования мочи. Затем производят хромоцистоскопию, рентгенографию и пиелоуретрографию.

**Прогноз.** Тяжелый.

**Лечение.** Распознанный туберкулез лечат в настоящее время хирургическим путем с удалением пораженной почки и последующим лечением стрептомицином; кроме того, проводят общеукрепляющее лечение больного, при невозможности оперативного лечения — стрептомициноterapia.

**УШИБ (CONTUSIO).** Повреждение мягких тканей с разрывом кровеносных сосудов, дающим кровоизлияние при отсутствии по-

вреждения кожных покровов. Свежие кровоизлияния дают темнobaгровую окраску покровов, а более старые — зеленую и желтую. С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Боль, припухлость ушибленного места, нарушение функций и видимое кровоизлияние. При окончании кровоизлияния (в течение одних суток) боли обычно стихают и остаются лишь при ощупывании поврежденного места. При значительном кровоизлиянии в ткани, иногда в течение нескольких дней, наблюдается повышение температуры до 39°, а ушиб весьма болезненных областей (больших нервных стволов, нервных сплетений, брюшной полости) может вызвать обморок и шок.

Л е ч е н и е. В течение первых часов после ушиба холод (холодные компрессы, пузырь со льдом и т. д. Покой. В дальнейшем, в зависимости от интенсивности ушиба, тепло (согревающие компрессы, грелки, ванны).

УШИВ МОЗГА см. *Мозга повреждения*.

ФИБРОАДЕНОМА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (FIBROADENOMA).

Для развития имеют значение гормональные нарушения.

Из доброкачественных опухолей молочной железы наиболее часто встречаются фиброаденомы. Опухоль состоит из эпителиальной и соединительной ткани.

С и м п т о м ы. Округлая опухоль, с гладкой поверхностью, плотной консистенции, не связанная с кожей, хорошо отграниченная от ткани железы, подвижная, медленно растущая. Возможен переход в рак.

Лечение. Ввиду трудности отличить от рака молочной железы в начальном периоде его развития и возможности перехода в рак фиброаденомы молочной железы подлежат оперативному лечению. ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ. К фиброзным дистрофиям относятся болезни костей, дегенеративные и дистрофические изменения с последующими восстановительными процессами в кости (на месте разрушенной кости образуется новая кость). Эти процессы в костях не связаны ни с воспалением, ни с опухолями.

К фиброзным остеодистрофиям относятся: фиброзный локализованный остит (костные кисты), гигантоклеточная «шухоль», генерализованный фиброзный остит или болезнь Реклингаузеи, болезнь Педжета.

Остеодистрофии развиваются главным образом у детей в возрасте от 5 до 8 лет и юношей в возрасте от 15 до 18 лет. Патогенез неизвестен. На месте образовавшихся кист кость истончается и может произойти перелом, который срастается хорошо. Развиваются костные кисты в метафизе кости.

Л е ч е н и е. Оперативное (выскабливание кист).

Болезнь Педжета. Характерна деформацией трубчатых костей нижних конечностей, ребер и черепа. Изменения при этой форме остита заключаются в увеличении длины и объема костей и их деформации. Так, например, толщина костей черепа достигает 2,5 см, а окружность увеличивается на 6—12 см. В длинных трубчатых костях утолщаются диафизы. Поверхность кости становится неровной, получается изогнутость кости. Патогенез болезни не выяснен. Клинически болезнь начинается с неопределенных болей, причем у лиц пожилого возраста.

Первым симптомом иногда является перелом или образование опухоли. Образующиеся деформации костей уродуют человека. На рентгеновском снимке можно видеть утолщение и искривление костей, а также чередование очагов склероза с очагами разрежения кости.

Болезнь тянется годами. Рационального лечения до настоящего времени нет.

Генерализованный фиброзный остит (болезнь Реклингаузеи). Принадлежит к редким формам остеодистрофии. Изменения в костях тождественны локализованной форме остита. Отличительной чертой этой формы является то, что процесс происходит во многих костях. Начало болезни мало заметно. Больные иногда жалуются на боли ревматического характера. Появляются утолщения мета-физов и диафизов. Кости становятся ломкими, искривляются при нагрузке; после переломов остаются укорочения и искривления. При поражении позвоночника образуются кифозы. Причина болезни объясняется повышенной функцией параситовидных желез.

Л е ч е н и е. Рентгенотерапия.

Гигантоклеточная опухоль или бурая опухоль. В настоящее время эти опухоли относят к дистрофическим процессам. Они не дают метастазов, напоминающих саркому.

Локализуются эти опухоли преимущественно в трубчатых костях, а также в плоских костях. Опухоли растут в течение 8—10 лет и не вызывают никаких болезненных симптомов. Вследствие хрупкости костей могут образоваться переломы с кровоизлиянием, что дало повод назвать эти опухоли бурными.

Опухоли поражают эпифизы костей. Функция суставов нарушается. При пальпации — болезненность и особый пергаментный хруст. Кожа блестящая, цианотичная, с развитой венозной сетью. На рентгеновском снимке обнаруживается вздутость эпифиза с множеством мелких кист. Кортикальный слой истончен. Периастиальных изменений нет. При диагностике возможно смешение с саркомой.

Л е ч е н и е. Рентгенотерапия.

ФИМОЗ. ПАРАФИМОЗ (PHYMOSIS. PARAPHYMOSIS). Врожденная узость кольца на месте перехода наружного листка крайней плоти во внутренний. Задерживающаяся в препуциальном мешке моча и смегма могут вызвать воспалительный процесс. Парафимоз, или удавка, происходит вследствие сдвига крайней плоти за головку члена при недостаточно широком отверстии препуциального мешка и сдавлении члена, в результате чего нарушается кровообращение головки члена и крайней плоти с появлением отека, а затем и омертвения.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Оттянуть крайнюю плоть и открыть головку невозможно. При очень маленьком отверстии мочеиспускание затруднено.

Л е ч е н и е. У детей при нерезко выраженной форме достаточно растягивания препуциального отверстия, и разделения клеек между головкой и крайней плотью. В сильно выраженной форме необходима операция. При парафимозе в свежих случаях, сдавливая пальцами головку члена, необходимо протолкнуть (вправить) ее через кольцо ущемления. При неудаче вправления производят



продольный разрез ущемляющего кольца по верхней поверхности и вправление головки. Во избежание повторения ущемления производят операцию фимоза.

**ФЛЕГМОНА (PHLEGMONE).** Гнойное воспаление клетчатки с омертвением тканей. Локализуется в подкожной жировой клетчатке, межмышечной и подфасциальной, подбрюшинной и тазовой клетчатке.

**Симптомы и течение.** Повышение температуры, общая разбитость, отсутствие аппетита, головная боль, озноб и другие признаки лихорадочного состояния. Местно наблюдается разлитая припухлость и краснота без резких границ, резкая болезненность и местный жар. Первоначально воспалительный инфильтрат характеризуется плотностью и отеком соседних тканей, затем образуется гнойное размягчение, иногда очень распространенное. При флегмонах нередко лимфангоиты, лимфадениты, тромбозы вен и разрушение стенки артерий с вторичным кровотечением. Возможно развитие общей гнойной инфекции.

**Лечение.** Покой для больной части тела (лежачее положение больного, шинная повязка и возвышенное положение пораженной части). Пенициллинотерапия и сульфаниламидотерапия. Иногда еще в стадии инфильтрации тканей делают разрезы для ослабления напряжения в тканях, предотвращения развития стаза крови, улучшения питания заболевших тканей и уменьшения таким образом омертвения тканей. На конечностях делают разрезы преимущественно по длине конечности, причем во избежание нарушения функции предпочитают длинным разрезам во всю длину флегмоны множественные, более мелкие (2—3 см на кисти и 5—7 см на остальных частях конечности). В последующем ведении больных обычно применяют бестампонные повязки. Омертвевшие ткани при перевязках, извлекают пинцетом, если они отходят без большого насилия; в противном случае ждут их отторжения. При перевязке внимательно осматривают, нет ли затеков и карманов, которые подлежат вторичному вскрытию.

**ФУРУНКУЛ (FURUNCULUS). ЧИРЕЙ.** Вызывается обычно стафилококком, реже стрептококком. Наиболее часто фурункулы появляются на тех участках кожи, где много сальных желез (спина, лицо), и на областях тела, кожа которых наиболее часто механически раздражается (шея, ягодицы, бедра). Появлению фурункулов способствует антисанитарная обстановка, несоблюдение личной гигиены (долгое несменяемое белье, редкие бани), расчесы угрей, наклонность кожи к экземам. Предрасполагающими моментами могут быть общее ослабление организма больного, хронические болезни, особенно диабет, анемии, инфекционные заболевания (тифы) и общее истощение больного при хронических инфекциях (туберкулез, сифилис), недостаточном питании и нервно-психическом переутомлении. Фурункул может, особенно при неправильном лечении (например, при выдавливании), дать воспаление лимфатических сосудов (лимфангоит), гнойное воспаление соседних лимфатических желез (лимфаденит) и общее распространение инфекции. Очень тяжелым и опасным осложнением является переход гнойного процесса на соседние вены и их воспаление (тромбофле-

# Р

бит). Наиболее часты эти осложнения при близости фурункула к большим венам, особенно на лице (область губы и носа), где это осложнение нередко ведет к быстрой смерти больного от тромбоза синусов мозга и общего гнойного заражения.

**Симптомы и течение.** Воспалительная инфильтрация в окружности волосяного мешочка, дающая поверхностное припухание, покраснение и уплотнение ограниченного участка кожи. Инфильтрированный участок возвышается над поверхностью кожи, имеет цианотично-красный цвет, плотен и болезнен; в центре соответственно выходу волоса отмечается черная или желтоватая точка. Общих лихорадочных явлений может не быть ввиду ограниченности процесса, но в некоторых случаях, особенно при фурункулах на лице, температура больного может подниматься до 39° и даже 40°. Обычно отмечается болезненность, функциональные расстройства, припухают и становятся болезненными регионарные узлы.

В центре инфильтрата происходит гангренизация волосяного мешочка с окружающей его клетчаткой, а в окружении — гнойное расплавление ткани. Соответственно вершине припухлости гной отслаивает эпидермис и имеет вид небольшого желтого пузырька. При его вскрытии свободного оттока гноя обычно не наступает, нока не выделяется вместе с гноем или не будет извлечен кусочек омертвевшей клетчатки кругом волосяного мешка — ка, имеющий характерную конусообразную форму (стержень) и закрывающий выход гною. По отхождении омертвевших тканей образуется гнойная полость, инфильтрат в окружности уменьшается, боль стихает и полость выполняется грануляциями, а затем рубцуется. Срок заживления — от нескольких дней до нескольких недель.

**Лечение.** Широко применяемым в настоящее время методом лечения отдельных фурункулов является введение под инфильтрат со стороны здоровой кожи 50 000—100 000 единиц пенициллина в 0,5% растворе новокаина. Хороший результат дает и внутримышечное введение пенициллина. В первые дни применяют горячие и световые ванны или облучение кварцевой лампой, аутогемотерапию по 10 мл через день.

Обсеменение фурункулами окружающих участков кожи наблюдается нередко при неправильном лечении (длительном применении согревающих компрессов, дающих сдвигание эпидермиса и появление новых фурункулов). При образовании гнойного расплавления ткани стержневая пробка гангрениозных тканей легко удаляется пинцетом, ^дальнейшем гранулирующая рана может быть прикрыта индифферентными мазевыми повязками.

**ФУРУНКУЛЕЗ (FURUNCULOSIS).** Часто наблюдается у слабых, истощенных больных или у больных с нарушенным обменом веществ, особенно тяжело протекает у больных сахарной болезнью.

**Лечение.** Кроме местного (см. *Фурункул*), необходима пенициллинотерапия и общее укрепляющее лечение (мышьяк под кожу, препараты железа, пивные дрожжи по столовой ложке три раза в сутки), светолечение (кварцевая лампа). Кроме того, рекомендуется тщательное соблюдение личной гигиены, частая смена белья, теплые ванны, исключение алкоголя, острой пищи и пряностей, лече-

ние расстройств обмена и хронических инфекционных заболеваний.

### **ЦИСТИТ. ВОСПАЛЕНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (CYSTITIS).**

Возбудители: наиболее часто кишечная палочка, стафилококк, стрептококк, гонококк и т. п.

**Симптомы и течение.** При остром цистите основной признак — частое и болезненное мочеиспускание, причем выводится небольшое количество мочи (20—30 мл). Моча мутная, содержащая гной. В конце мочеиспускания может выделяться пемного крови. Температура субфебрильная или нормальная. Через несколько дней при соблюдении режима и лечении процесс затихает. Длительность болезни 10—15 дней. При хроническом цистите все явления выражены слабее; мочеиспускание менее учащено, мало болезненно; моча мутная.

**Лечение.** Тепло (грелки, сидячие ванны, согревающие компрессы); в некоторых случаях прибегают к наркотикам, свечи с белладонной. Из дезинфицирующих средств применяют пенициллин, уротропин, салол, стрептоцид и т. п. По стихании острых явлений назначают промывание пузыря слабыми растворами ляпис (1:5 000) с доведением раствора до 1:1 000 или окисиангистой ртути 1 : 4 000 до 1 : 2 000 и раствор риванола 1 : 1 000. Диета молочная и вегетарианская.

При хроническом цистите — устранение причины, после чего то же лечение, что и при остром.

**ШОК ТРАВМАТИЧЕСКИЙ.** Наблюдается после ранений, ушибов, тяжелых операций и распространенных ожогов. Раздражение при ранении большого числа чувствительных нервов и их окончаний дает мощный поток импульсов в центральную нервную систему, реакция которой и выявляется в картине шока. Громадное значение имеют функциональные изменения в нервной системе, предрасполагающие к развитию шока: повышение нервно-психической возбудимости, предшествовавшие травме психические потрясения и переживания, физическое переутомление, истощение и голодание, охлаждение, кровопотеря, длительное неудобное положение пострадавшего при транспортировке.

Клинически различают ранний шок, который развивается непосредственно вслед за травмой, и поздний, развивающийся спустя некоторое время после ранения или произведенных операций.

**Симптомы и течение.** По картине болезни различают два периода шока: эретический (протекающий с возбуждением) и торпидный (вялый). В эретическом периоде шока наблюдается состояние возбуждения и страх с беспокойными движениями в конечностях в сочетании с бессонницей; лицо покрасневшее, пульс частый и малый. Для торпидного периода характерна апатичность, безучастное состояние больного при сохранении им сознания, падение кровяного давления, учащение пульса до 120 ударов в минуту и выше (до полного исчезновения пульса). Дыхание поверхностное, учащенное, температура пониженная, количество мочи уменьшено. При осмотре больного отмечают бледность покровов, холодный пот; лицо осунувшееся, зрачки расширены, плохо реагируют на свет; нередко наблюдается тошнота, икота, рвота.

**Профилактика.** Для раненого должны быть созданы условия полнейшего покоя. В тех случаях, когда ранение может быть болезненным (например, открытые переломы конечностей, полостные ранения), больного транспортируют в шинной повязке и обеспечивают ему максимальные удобства, покой и быстроту доставки. При первой возможности таким раненым вводится 1 мл 1% раствора морфина или 2 мл 2% раствора пантопона; дается алкоголь.

**Лечение.** Устранение причины, вызвавшей шок, уменьшение болевых ощущений, остановка кровотечения и т. д. Голове больного придают низкое положение, согревают больного, дают ему пить, назначают возбуждающие средства: алкоголь, крепкий кофе, чай. Инъекции адреналина, камфоры и кофеина. Громадное значение имеет применение внутривенных вливаний больших количеств физиологического раствора или 5% раствора глюкозы, жидкости Ас-ратана и других противошоковых растворов и переливание крови. Производят только неотложные операции, необходимые для спасения жизни, например, остановка кровотечения; в прочих случаях сначала выводят больного из состояния шока, а затем оперируют.

**ЭЛЕКТРОТРАВМА.** Возникает при прикосновении к незаизолированным включенным в сеть проводам, а при высоковольтном токе — при приближении к токоведущей части, при коротком замыкании или ударе молнии вблизи пострадавшего.

**Симптомы.** Потеря сознания, остановка дыхания, судорожное сокращение мышц. Если действие тока не прекратится — быстро наступает смерть, нередко состояние мнимой смерти. Местные изменения в месте входа и выхода тока, небольшие раны с некрозом тканей на поверхности и в глубине, знаки тока на коже, иногда ожоги.

**Лечение.** Немедленно прекратить дальнейшее действие тока на пострадавшего. При состоянии мнимой смерти — немедленно на месте происшествия искусственное дыхание до восстановления нормального (несколько часов) или до появления несомненных признаков смерти. Пострадавший подлежит госпитализации ввиду возможности наступления вторичных патологических расстройств. При падении сердечной деятельности назначают возбуждающие средства. Лечение электроожогов. См. *Ожоги*.

**ЭПИДИДИМИТ. ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКА ЯИЧКА (EPIDIDIMITIS).** Наиболее часто развивается как осложнение гонорейного уретрита.

**Симптомы и течение.** Острый эпидидимит протекает бурно: резкие боли, температура повышается, придаток увеличивается, становится резко болезненным, половина мошонки увеличивается в размере, кожа краснеет, складки ее сглаживаются. Острый период длится 5—7 дней.

**Лечение.** Сульфаниламидные препараты (по 2,0—3,0 в день), пребывание в постели с приподниманием мошонки суспензорием, тепло, компрессы, свечи с белладонной или морфином, пенициллин.

**ЭПИСПАДИЯ (ОТСУТСТВИЕ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА) И ГИПОСПАДИЯ (ОТСУТСТВИЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА).** Гипоспадия и эписпадия относятся к врожденным ано-

малиям. При гипоспадии наружное отверстие уретры расположено на нижней (задней) поверхности. Член иногда искривлен, при промежуточной форме гипоспадии (ложный гермафродитизм) мошонка расщеплена по средней линии и очень похожа на женские половые губы; недоразвитый член принимается за клитор, а расположенное в глубине отверстие уретры — за влагалище, у ребенка может быть одновременно крипторхизм. При эписпадии наружное отверстие уретры расположено на верхней (передней) стенке; член искривлен вверх.

**Лечение** — пластические операции.

**ЭХИНОКОКК (ECHINOCOCCUS)**. Пузырчатая стадия ленточного глиста, обитающего в кишечнике собаки. Выделяющиеся с испражнениями яйца глистов при загрязнении рук, овощей и т. д. попадают в кишечник человека. После растворения оболочки яйца зародыши внедряются в стенку кишки, попадают в вены и с током крови в капилляры печени; здесь и задерживаются наиболее часто, проходя пузырчатую стадию. Пузырь эхинококка окружен соединительнотканной капсулой, развивающейся из пораженного органа. Внутри пузыря содержится жидкость, зародыши и дочерние пузыри. Пройдя капилляры печени, зародыши эхинококка могут задержаться в капиллярах легкого (эхинококк легкого) или попасть с током крови в любой орган.

**Симптомы**. Характерно бессимптомное появление большой, округлой эластической опухоли какого-либо органа. При сдавливании соседних органов увеличенным пузырем — функциональные нарушения и боли. В крови эозинофилия. Уточняют диагноз специальными реакциями.

**Осложнение** — нагноение эхинококка, вскрытие в серозные полости (шок, крапивница, обсеменение — появление множественных кист в брюшной полости и плевре).

**Лечение**. Хирургическое иссечение или рассечение пузыря с удалением содержимого.

**ЭХИНОКОКК ПЕЧЕНИ (ECHINOCOCCUS HEPATIS)**. Чаше эхинококк поражает правую долю печени в виде бдного большого пузыря, содержащего прозрачную янтарного цвета жидкость, в которой плавают крючья и дочерние пузыри эхинококка. Такой эхинококк называется однокамерным. При альвеолярном эхинококке находят многочисленные желтые узлы с кистами величиной с горошину.

**Симптомы и течение**. При росте опухоли иногда жалобы на чувство тяжести. Токсическое действие паразита вызывает появление крапивницы, тошноту, рвоту, поносы. Опухоль растет медленно. При альвеолярном эхинококке наблюдаются желтухи. При исследовании печень плотна, бугриста. Эхинококк может нагноиться, повышается температура, появляется озноб.

**Распознавание**. Увеличенное количество эозинофилов в крови. Положительная кожная реакция Кацони. Проколы эхинококкового пузыря противопоказаны. Дифференцируется с непаразитарными кистами, абсцессами печени, водянкой и эмпиемой пузыря, кистами поджелудочной железы, гидронефрозом, гуммами печени.

**Лечение**; Оперативное.

**ЯЗВЫ (ULCERA)**. Различают язвы трофические, раковые, сифилитические, туберкулезные, цинготные, варикозные и простые. Последние являются следствием продолжительного механического, химического и температурного раздражения, которое мешает заживлению язвы.

Трофические язвы имеют в основе различные страдания центральной нервной системы и периферических нервов; отличаются особым упорством, плохо поддаваясь каким бы то ни было лечебным мероприятиям.

**Симптомы и течение**. Гранулирующая поверхность нередко с грязным и некротическим дном, плотными, иногда покрытыми краями, не имеющая наклона к заживлению. Язва имеет склонность распространяться вглубь и вширь, инфицируясь, дает лимфангоиты, иногда вспышки рожистого процесса, отек и инфильтрацию тканей в окружности.

**Лечение**. В зависимости от характера язвы, лечение различно: при раковой язве — оперативное, при сифилитической — специфическое, при туберкулезной — светолечение и общее лечение, при простой язве — местное применение индифферентных мазевых повязок (стерильный вазелин, рыбий жир). При лечении трофических язв применяют воздействия на нервную систему (блок по Вишневскому).

**ЯЗВА ГОЛЕНИ ВАРИКОЗНАЯ (УЗЛОВАТАЯ) (ULCUS CRURIS VARICOSA)**. Развивается на почве расстройства кровообращения при расширении вен бедра и голени. Возникает обычно из небольших кожных ссадин, расчесов и фурункулов, ведущих к образованию изъязвлений, которые не заживают из-за ослабленного питания тканей.

**Симптомы и течение**. Язвы круглой или овальной формы с пологими краями, дно покрыто вялыми цианотичными грануляциями с серо-гнойным налетом, а отделяемое нередко со зловонным запахом. При длительном течении в окружности язвы появляется бурокоричневая пигментация. Малая склонность к заживлению, длительное течение, склонность к рецидивам, нередкие кровотечения из прорвавшихся расширенных вен. Отечность и повторные рожистые воспаления могут повести к слоновости конечности.

**Лечение**. Для улучшения кровообращения необходимо лежачее положение с приподнятой ногой или сдавление вен путем бинтования эластическим трикотажным бинтом. Винтуют утром в постели, начиная со стопы до средней трети бедра, равномерно сдавливая конечность. Бинт снимают только на ночь. Для улучшения кровообращения — повязка из пасты Унна: окиси цинка 100,0, желатины 200,0, воды 300,0, глицерина 400,0. При наложении повязки берут кусок массы, распускают ее в сосуде, поставленном в горячую воду, и намазывают с помощью кисти бинт, которым забинтовывают стопу и голень. Повязку меняют через 10—15 дней. На язву можно также наложить черепицеобразно полоски липкого пластыря или сделать повязку из мази Вишневского, стерильного вазелина или рыбьего жира.

**ЯЗВА ПЕПТИЧЕСКАЯ (ULCUS PEPTICUM)**. Развивается после операции на желудке (гастроэнтеростомии, резекции желудка) сиу-

стя несколько месяцев и даже лет. Располагается она в области анастомоза на приводящей петле и часто сопровождается образованием инфильтрата. Язва быстро прогрессирует и имеет склонность к прободению. В некоторых случаях образуется свищ, соединяющий желудок и поперечноободочную кишку.

**Симптомы.** Боли в подложечной области, в области пупка, тошнота, рвота, исхудание, высокая кислотность. Самопроизвольное заживление не часто. **Лечение** оперативное.

**ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОН КИШКИ** см. гл. I *Внутренние болсти.*

**ЯЗЫКА ОСТРОЕ ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ (GLOSSITIS PURULENTA).** Наблюдается на почве повреждений языка, при нагноении десен, ран, при язвенном стоматите.

**Симптомы и течение.** В языке образуется инфильтрат, отек и болезненность. В дальнейшем появляются гнойники, на дне полости рта развивается флегмона. Затруднение при приеме пищи, жидкостей; создается угроза дыханию. Обильное слюнотечение. Температура высокая, интоксикация. В тяжелых случаях может развиваться общее заражение, пневмония и отек голосовой щели. **Лечение** оперативное.

## Г Л А В А VII

### АКУШЕРСТВО

**АБОРТ, ИЛИ ВЫКИДЫШ (ABORTUS).** Искусственное или самопроизвольное прерывание беременности в первые семь лунных месяцев. Различают: ранний аборт (ранее 16 недель беременности) и поздний аборт (между 16 и 28 неделями). Самопроизвольный аборт может произойти вследствие ряда причин: неполноценное, плодное яйцо, половой инфантилизм (недоразвитие половых органов — «детская матка»), алкоголизм и морфинизм родителей, хронические инфекции, тяжелые формы туберкулеза с резкой интоксикацией организма матери, сифилис, а также острые инфекции, сопровождающиеся высокой температурой (тифы, пневмония, малярия, грипп и т. д.), заболевания желез внутренней секреции, недостаточность желтого тела, нервные потрясения и т. д.

**Симптомы и течение.** Различают: 1) угрожающий аборт (abortus imminens): болезненные схватки, шейка еще закрыта, яйцо не отделилось; в результате предпринятых мероприятий беременность может развиваться дальше; 2) начинающийся аборт (abortus incipiens): болезненные схватки, шейный канал несколько расширен, кровянистые выделения, яйцо частично отделилось; 3) аборт «в ходу»: внутренний зев открыт, шейка сглажена, болезненные схватки, обильные кровянистые выделения, плодное яйцо целиком или большей своей частью отделено; 4) полный аборт (abortus completus): плодное яйцо целиком вместе с отпадающей оболочкой выделено; в матке нет остатков плодного яйца (если плодное яйцо временно задержалось у наружного зева, то в таком случае получается так называемый цервикальный, или шеечный, аборт); 5) неполный аборт (abortus incompletus): плодное яйцо не вышло целиком, в матке задержались некоторые части плода или плаценты, при этом матка не может равномерно сократиться и вследствие этого нередко отмечается довольно обильное кровотечение. Иногда кровяные сгустки задерживаются на остатках детского места, постепенно нагнаиваются, друг на друга, подвергаются организации и превращаются в плотное образование, носящее название **плацентарного полипа**.

В том случае, когда отслойка плодного яйца происходит медленно, возможно рассасывание зародыша, а остатки яйцевых оболочек вместе со свернувшейся кровью превращаются в бесформенную массу, носящую название **кровоного заноса**. Если кровяной занос находится в матке долгое время, гемоглобин крови выщелачивается и занос получает более светлый оттенок — **мясистый занос**.

В редких случаях спустя некоторое время схватки и кровотечения совершенно прекращаются и яйцо остается очень долгое время в матке, не вызывая никаких симптомов (задержавшийся выкидыш — missed abortion).

**Распознавание** — на основании приведенных выше данных. Основное значение имеет анамнез, наличие кровянистых выделений или маточное кровотечение, схваткообразные боли внизу живота.

**Лечение.** Если шейка закрыта, кровянистые выделения незначительны (abortus imminens — угрожающий выкидыш) и есть надежда на сохранение беременности, необходимо уложить больную в постель, предоставив ей полный физический и психический покой. Для уменьшения схваток назначают препараты брома, валерианы или наркотики (пантопон, морфин под кожу, опий -3 раза в день по 8 капель внутрь). Противопоказаны тепло и холод на живот. При угрожающем аборте хорошие результаты дают инъекции гормона желтого тела. Рекомендуется внутримышечное введение прогестерона (действующее начало желтого тела) по 1 мл (в каждом миллилитре содержится 5 мг прогестерона): первые 5 дней вводят прогестерон 2 раза в день, утром и вечером, последующие 10 дней — по одному разу в день. Прогестерон рекомендуется не только при угрожающих выкидышах, но и в качестве профилактического мероприятия у женщин, которые, страдают привычным выкидышем. Для профилактики выкидыша при преждевременных родов рекомендуется в течение беременности проводить инъекции прогестерона по 1 мл (=5 мг) ежедневно в течение первых 10 дней II, IV и VII месяца беременности.

Если надежды на сохранение беременности нет, аборт заканчивают выскабливанием (операцию производит врач). Если в полости матки имеются остатки плодного яйца и у больной отмечается лихорадочное состояние (инфицированный аборт), то в случае сильных кровотечений оперативное вмешательство должно быть произведено в целях спасения больной от резкой анемии. При отсутствии кровотечений неполный лихорадочный аборт лучше вести консервативно: холод на низ живота, внутрь сульфаниламидные препараты (4—6 раз в день по 1,0 сульфидина, сульфазола, сульфадиазина, норсульфазола), под кожу — пенициллин по 50 000 единиц через 3 часа в течение нескольких дней (до падения температуры); для сокращения матки назначают хинин, стиптицин (3 раза в день по 0,05). Для усиления сокращений матки рекомендуется инъекция питуитрина (гормон задней доли гипофиза) или маммо-физина (комбинация гормонов задней доли гипофиза и грудной железы) по 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день. После установления нормальной температуры при наличии кровотечения производят выскабливание. Обязательна госпитализация.

Rp. Stypticini 0,05  
Sacchari 0,25  
M. f. pulv. D. t. d. N. 20 DS. 3 раза в  
день по 1 порошку

Rp. Mammopbysini in amp. a 1,0 D. t. d. N. 6  
DS. По 1 ампуле внутримышечно

Rp. Pituiticini P in amp. a. 1,0 D. t. d. N. 6 DS.  
По 1 ампуле внутримышечно

**АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В АКУШЕРСТВЕ.** Точно так же как и в хирургии; в акушерстве асептика играет огромную роль в отношении обеспечения здоровья и сохранения жизни как матери, так и ребенка. Родовые пути как во время родового акта, так и в послеродовом периоде представляют обширную раневую поверхность, которая может быть легко инфицирована, если не соблюдать самых строгих мер асептики и антисептики. Опасность в смысле инфицирования представляет не только раневая поверхность матки, но и мельчайшие надрывы в области шейки матки, трещины слизистой оболочки влагалища, разрывы промежности и т. п. Основная задача акушерской асептики заключается в том, чтобы все раневое поле, все мельчайшие трещины оградить от попадания возбудителя инфекции. Кроме того, в настоящее время хорошо известно, что поражение не только половых путей, но и инфицирование, например, носоглотки, желудочно-кишечного тракта и др. представляет также большую опасность в смысле возможности переноса инфекции из этих очагов в родовые пути. Следовательно, необходимо остерегаться не только экзогенной, но и эндогенной инфекции. Однако наибольшую опасность представляет экзогенная инфекция, т. е. инфекция, занесенная извне в половой тракт роженицы или родильницы.

В целях профилактики септического заболевания как во время, так и после родов необходимо строго соблюдать ряд мер. В каждом родильном доме должно быть специальное отделение для рожениц с повышенной температурой. Поэтому перед определением роженицы в то или иное отделение необходимо заранее измерить у нее температуру. Температурирующая женщина должна находиться в отдельном изолированном помещении. Необходимо также изолировать женщин, поступающих в родовспомогательное учреждение, от зкеищин, поступивших с начавшимися дома или на улице родами, а также рожениц, страдающих гнойничковыми и другими конными заболеваниями. В каждом родильном доме должен быть санитарный пропускник, откуда роженицы после санитарной обработки направляются в соответствующее отделение, а выписывающиеся из родильного дома родильницы выходят через отдельный ход.

При поступлении роженицы ставят клизму, затем сбывают волосы с наружных половых органов; после этого роженица направляется в душевую, где ее обмывают. Обмывать роженицу в ванне не рекомендуется, так как загрязненная вода может попасть во внутренние половые органы женщины и внести инфекцию.

После санитарной обработки роженица надевает чистое свежее выглаженное белье и направляется в родильный зал (родовую комнату).-

Врачи и акушерки, принимающие роды, должны готовиться к родам, как к серьезной операции: тщательно вымыв руки стерильными щетками с мылом, они обрабатывают их спиртом и иодом. Наружные половые органы роженицы тщательно дезинфицируют спиртом, иодом. Спринцевание влагалища перед родами не рекомендуется. Под таз роженицы подстилают стерильное белье; все материалы, употребляемые при приеме родов (вата, марля, а также и инструменты), должны быть тщательно дезинфицированы (стерилизация, кипячение и т. д.). Персонал, принимающий роды и находящийся в родильной комнате, должен быть в марлевых масках. Желательно принимать роды в резиновых перчатках и почаще обмывать руки 1% раствором лизола.

Внутреннее исследование во время родов должно быть ограничено (при наличии серьезных показаний) так как введение во влагалище и особенно в матку руки, даже педантично обработанной по всем правилам асептики и антисептики, может повлечь за собой внесение инфекции.

После родов в течение всего времени пребывания родильницы в родовспомогательном учреждении необходимо производить так называемую «уборку» родильницы не менее двух раз в день. При этом наружные половые органы обмывают струей теплой кипяченой воды из кувшина или кружки. Обмывание производится ватой на корнцанге или длинном пинцете; затем ватой, смоченной в дезинфицирующем растворе, обмывают наружные половые органы и высушивают сухой ватой или марлей, также захваченной корнцангом или длинным пинцетом, причем для каждой родильницы следует брать отдельный инструмент.

Каждая роженица и родильница должна быть обеспечена индивидуальным продезинфицированным судном.

**АСФИКСИЯ (УДУШЬЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ).** Различают асфиксию внутриутробную и асфиксию новорожденных.

Асфиксия внутриутробная. Нарушение газообмена утробного плода. Наиболее частыми причинами асфиксии является сдавливание пуповины, выпадение, обвитие, нарушение кровообращения вследствие преждевременной отслойки плаценты, в некоторых случаях предлежания плаценты, при частых интенсивных схватках и потугах, когда энергичные сокращения мышц матки нарушают плацентарное кровообращение. При этом сердцебиение плода в начальных стадиях урежается, что можно объяснить накоплением в крови плода углекислоты или раздражением блуждающего нерва. В дальнейшем увеличивающееся накопление углекислоты в крови плода ведет к параличу блуждающего нерва, а сердцебиение, наоборот, учащается, достигая 200 и более ударов в минуту.

Частая проверка сердцебиения плода является одним из обязательных моментов ведения родов: число ударов ниже 100 и выше 160 в минуту должно направить мысль врача или акушерки на асфиксию плода.

При первых признаках наступающей внутриутробной асфиксии необходимо принять срочные меры к быстрому родовспоможению: поворот на ножку и извлечение, наложение щипцов. В случае отсутствия условий для этого нужно стремиться к усилению окислительных процессов в организме матери вдыханием кислорода, внутривенным введением глюкозы, введением сердечных: камфоры, коразола и др.

Метод А. П. Николаева и Тюриной заключается в следующем: 1) роженице дают вдыхать кислород, 2) одновременно роженице вводят в вену 50 мл 40% раствора глюкозы или дают ей выпить полстакана теплой воды, в которой растворено 5 кусков сахара, и 3) внутримышечно роженице вводят 1 мл кардиазола, коразола. Если сердцебиения плода выравниваются, через час профилактически повторяют весь комплекс, если же выравнивание не наступило, весь комплекс повторяют через 10—15 минут.

Асфиксия новорожденных. Наиболее частыми причинами асфиксии новорожденных являются те же, что и асфиксии внутриутробного плода: выпадение, обвитие, прижатие пуповины, предлежание или преждевременная отслойка детского места.

Асфиксия наблюдается при длительных родах (слабая родовая деятельность, узкий таз, атипичное предлежание) и после акушерских операций (наложение щипцов, поворот на ножку, извлечение за тазовый конец), которые часто приводят к внутричерепным кровоизлияниям, в результате чего наступает асфиксия.

В зависимости от того, насколько асфиксия прогрессировала до момента родов, различают две степени асфиксии: первая, более легкая, так называемая с и н я а с ф и к с и я, и вторая, более тяжелая, б л е д н а я, или б е л а я а с ф и к с и я.

В первом случае кожа новорожденного сине-красная, несколько отечная, сердцебиение замедленное, ощущается сильная пульсация артерий, сосуды пуповины туго наполнены кровью. Мышечный тонус сохранен.

При белой асфиксии кожа резко бледна и холодна наощупь, мышечный тонус отсутствует, конечности свисают, .сосуды пуповины едва пульсируют, сердцебиение слабое, еле прослушиваемое.

**Лечение.** В первую очередь приступают к освобождению дыхательных путей новорожденного от слизи. Для этого, оттянув вперед язык, в гортань вводят мягкий катетер, соединенный с резиновым баллоном, которым освобождают дыхательные пути от закупоривающей их слизи. Не перерезая пуповины, ребенка помещают в теплую ванночку, которую ставят между ногами матери. Все манипуляции (освобождение от слизи и др.) производят во время нахождения новорожденного в ванночке (Легенченко). Если к этому прибавить растирание спинки полотенцем, то в легких случаях этого достаточно для восстановления нормального дыхания.

Однако при белой асфиксии этих мероприятий недостаточно. Если они не приводят к установлению нормального дыхания, пол' кожу вводят 1 мл следующей смеси: 10% камфорного масла, 1% раствор лобелина и 0,5 мл 1(1% раствора кофеина. Очень осторожно и бережно производят искусственное дыхание.. Необходимо помнить, что асфиксия новорожденного нередко является следствием внутри-

черепного кровоизлияния. Для раздражения дыхательного центра ребенка в ноздрю вводят катетер, конец которого надет на щланг подушки с углекислотой; одновременно дают вдыхать кислород.

После оживления необходимо установить тщательное наблюдение за ребенком, так как нередко у детей, родившихся в асфиксии, в дальнейшем развивается пневмония.

**АТОНИЧЕСКИЕ (ГИПОТОНИЧЕСКИЕ) КРОВОТЕЧЕНИЯ.** Наблюдаются главным образом после рождения последа.

**Причины.** Иерастяжение стенок матки во время беременности (многоводие, двойни, крупный плод) и вследствие этого слабая родовая деятельность и недостаточная сократительная способность матки после родов. Слабая родовая деятельность, обусловленная другими причинами (нарушение функции эндокринной, вегетативно-нервной системы), в дальнейшем, после родов, сказывается плохим сокращением послеродовой матки; недостаточное сокращение в послеродовом периоде наблюдается также в тех случаях, когда во время беременности и родов имели место токсикозы.

Таким образом, перечисленные моменты должны заставить врача и акушерку быть настороже, так как в таких случаях можно ожидать гипотонического кровотечения после рождения плаценты.

**Лечение.** Массаж матки через наружные брюшные покровы, внутримышечное введение 1 мл питуикрина или маммефизина.

В случае отсутствия эффекта — ручное обследование полости матки (строгая асептика!).

В случае наличия остатков, долек плацентарной ткани — отделить их от стенки матки и выделить наружу.

Если после удаления остатков детского места или после того, как врач удостоверится в том, что в матке таковых не оказалось, кровотечение продолжается, производят массаж матки через брюшные покровы, введя вторую руку, сжатую в кулак, в полость матки («массаж на кулаке»).

Обычно эта манипуляция дает хорошие результаты, но через некоторое время кровотечение может повториться; матка опять расслабляется («распускается»). В таких случаях необходимо приступить к тампонаде полости матки.

**Техника тампонады.** Шейку матки обнажают влажными зеркалами и захватывают пулевыми щипцами, лучше двухзубцами, так как шейка очень истончена и при наложении пулевых щипцов часто рвется. Затем корнцангом захватывают конец широкого бинта, доводят его до дна матки и постепенно туго заполняют всю полость. Тампон удаляют через 18—24 часа.

В случае сильного кровотечения во время выполнения манипуляции тампонады помощник производит прижатие аорты тугим валиком или же кулаком.

В случае отсутствия эффекта производят чревосечение для ампутации матки.

При кровопотере больше 500—600 мл делают переливание крови, вводят под кожу физиологический раствор, 5% раствор глюкозы; назначают сердечные средства.

Для профилактики септических заболеваний в послеродовом периоде в течение 3—4 дней назначают пенициллин по 50 000 единиц через каждые 3 часа и сульфаниламидные препараты по 1 г 4—5 раз в день (см. *Задержка плаценты*).

**БЕРЕМЕННОСТЬ ВНЕМАТОЧНАЯ (GRAVIDITAS EXTRA-UTERINA).** При внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка прививается не в матке, а в трубе, в яичнике и в брюшной полости. Соответственно этому различают трубную, яичниковую и брюшную беременность.

Яичниковая и брюшная беременность встречается чрезвычайно редко. Практически приходится большей частью встречаться с трубной беременностью.

Наиболее часто оплодотворенное яйцо прививается в ампулярной части трубы.

**Причины** развития внематочной беременности в огромном большинстве случаев является воспалительное заболевание труб.

При воспалительных заболеваниях труб нарушается функция мерцательного эпителия и понижается сократительная перистальтическая способность труб, вследствие чего оплодотворенное яйцо не опускается в полость матки, а прививается в трубе.

Другой причиной наступления трубной беременности является половой инфантилизм. При этом фаллопиевы трубы значительно удлинены, извилисты; мускулатура труб неценна. Вследствие этой неполноценности и слабости перистальтики труб оплодотворенное яйцо не опускается в матку и прививается к стенке трубы.

Помимо инфантилизма и воспалительных явлений, в развитии внематочной беременности большую роль играют неправильности развития самого оплодотворенного яйца. Быстрые темпы развития оплодотворенного яйца приводят к образованию трофобласта, в то время как оплодотворенное яйцо еще находится в трубе.

Значительную роль в развитии воспалительных процессов труб играют частые аборт, гоноррея.

Внутриматочные впрыскивания йодной настойки, применяемые некоторыми в качестве противозачаточного средства, приносят огромный вред, так как попадающий при этом в просвет трубы йод вызывает ряд изменений в слизистой оболочке трубы, что может поспособствовать образованию внематочной беременности.

Обычно трубная беременность прерывается на 4—6-й неделе.

Различают два исхода внематочной беременности: трубный аборт и разрыв трубы. В первом случае происходит отслойка плодного яйца, начинаются антиперистальтические сокращения трубной мускулатуры и отслоившееся плодное яйцо продвигается к ампулярному концу трубы. Этот исход менее опасен, чем разрыв трубы, при котором может наступить весьма сильное, угрожающее жизни больной внутреннее кровотечение.

**Симптомы и течение.** В первые недели беременности особых симптомов не отмечается. Наблюдаются обычные симптомы, которые имеют место при нормальной маточной беременности, т. е. прекращаются менструации, наступают тошноты и рвоты. На 4—6-й неделе после последних правильных менструаций наступают

резкие боли, нередко обмороки, беременная чрезвычайно бледна, живот несколько вздут, болезнен при пальпации; отмечаются явления раздражения брюшины и внутреннего кровотечения.

Нередко наблюдается и другая картина течения внематочной беременности: последние менструации восемь-десять недель назад; в последние дни появились кровянистые выделения и схваткообразные, иногда очень интенсивные боли внизу живота. Выделения незначительные, кровянистые, темные, густые, дегтеобразные.

При внутреннем исследовании удастся установить, что величина матки не соответствует сроку беременности, — она несколько меньше. Рядом с маткой, справа или слева, иногда удастся прощупать колбасовидную пульсирующую опухоль тестоватой консистенции. В случае, если произошел разрыв трубы и кровоизлияние в заднее дугласово пространство, ощущается легкая флюктуация или пастозность (наличие сгустков крови).

В установлении диагноза внематочной беременности огромную роль играет анамнез: инфантилизм, воспалительные заболевания половых органов, бесплодие или большой перерыв между настоящей беременностью и предыдущей (в случаях, когда не применялись противозачаточные средства). В сомнительных случаях для установления диагноза беременности ценную услугу может оказать реакция Ашгейм-Цондека. В случае подозрения на внутреннее кровотечение производят пункцию заднего свода влагалища.

**Лечение.** Немедленная операция. При сильной степени потери крови — переливание крови (до 1 л). Во время операции, не дожидаясь окончания ее, под кожу вводят физиологический раствор или 5% раствор глюкозы (1 000—2 000 мл); сердечные средства. В случаях запущенной внематочной беременности с возможным инфицированием излившейся в брюшную полость крови в послеоперационном периоде назначают сульфаниламидные препараты, пенициллин (по 50 000 единиц через 3 часа в течение 2—3 суток). **ВОДЯНКА (ОТЕК БЕРЕМЕННЫХ).** Отеки появляются в последние три-четыре месяца беременности и в дальнейшем нарастают. Отеки связаны с нарушением обмена веществ, задержкой в тканях воды, поваренной соли.

**Симптомы и течение.** Беременные отмечают отек во второй половине дня и после длительного стояния (объем становится «узкой»). Отекают чаще всего нижние конечности, лицо, брюшные стенки, наружные половые органы; белок в моче отсутствует, кровяное давление нормальное.

Большую опасность представляют быстро нарастающие отеки, которые могут перейти в эклампсию.

**Лечение.** Постельное содержание, ограничение введения жидкости, бессолевая диета, сухоядение, исключение экстрактивных веществ. При значительных отеках — внутримышечное введение 20—30 мл 25% раствора сернокислой магнезии 1—2 раза в день (повышает диурез).

**Профилактика.** Беременные женщины должны посещать женскую консультацию не реже одного раза в месяц, а в последние три месяца беременности — не реже чем каждые две недели. В консультации отмечается вес, кровяное давление, а также исследуется

моча на белок. При значительном и быстром нарастании веса (более 300 г в неделю) необходимо подумать о наличии «скрытых отеков». Такие беременные должны быть взяты на специальный учет, а при прогрессирующем нарастании веса — направлены в родовспомогательное учреждение для стационарного лечения.

**ВЫПАДЕНИЕ МЕЛКИХ ЧАСТЕЙ ПЛОДА.** Выпадение мелких частей плода чаще всего встречается при узком тазе, при поперечном или косом положении плода, а также при ягодичном предлежании, так как после отхождения вод ягодичцы полностью не закрывают просвета входа в таз.

Выпадение мелких частей плода при головном предлежании встречается реже. Выпадение мелких частей плода может произойти при маленькой головке плода или при неправильном вставлении головки, при многоводии, особенно у повторнородящих.

Практическое значение имеет выпадение ручки.

**Ведение родов.** Если воды отошли час или два назад, плод при наружном исследовании подвижен, то при наличии полного открытия зева и высоко расположенной предлежащей части можно попытаться осторожно сделать поворот на ножку с последующим извлечением плода.

Если поворот не удастся, его ни в коей мере не следует форсировать, так как энергичное поворачивание плода после отхождения вод может повлечь за собой разрыв матки.

Выпавшую ручку при поперечном положении плода никогда не следует вправлять. Если воды отошли давно, никаких попыток к повороту делать не следует.

В случае запущенного поперечного положения плода акушерка должна немедленно вызвать врача (эмбриотомия!).

После операции поворота и извлечения назначают пенициллин через 3 часа по 50 000—100 000 единиц и сульфаниламидные препараты внутрь 4—5 раз в день по 1 г.

**ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ.** Встречается при поперечном или косом положении плода, при узком тазе, при ягодичном предлежании плода.

Выпадение пуповины встречается чаще, чем выпадение других мелких частей плода. Часто выпадение является следствием предлежания пуповины и происходит в момент разрыва плодного пузыря. Однако выпадение пуповины может произойти и без предварительного ее предлежания.

Если ко времени отхождения вод головка плода еще остается подвижной, роженице запрещают ходить; чтобы определить возможность выпадения пуповины, производят влагалищное исследование.

Выпадение пуповины является серьезной угрозой для жизни плода, так как прижатие предлежащей частью плода пуповины к стенке таза влечет за собой нарушение кровообращения плода, его асфиксию и смерть.

**Распознавание.** Ухудшение сердцебиения плода при ■высоко стоящей предлежащей его части после отхождения вод является серьезным показанием к внутреннему исследованию, так как в таком случае можно предполагать, что причиной ухудшения сердцебиения плода является выпадение пуповины.



При влагалищном исследовании прощупывается петля пуповины; пульсация пуповины свидетельствует о наличии живого плода. Однако если прощупывание петли пуповины происходит во время схваток, ощутить пульсацию сосудов не удастся даже при живом плоде; поэтому необходимо подождать, пока не прекратится схватка.

Если пуповина выпадает между передней стенкой таза и предлежащей частью плода, опасность прижатия ее значительно больше, чем тогда, когда она прощупывается в области крестцово-под-вздошной впадины.

**В е д е н и е р о д о в . П р о ф и л а к т и к а .** Если при внутреннем исследовании определяется предлежание пуповины и воды целы, все мероприятия направляются на предупреждение преждевременного разрыва плодного пузыря. Для этого роженицу укладывают на бок и не разрешают ей тужиться.

Предупреждение преждевременного разрыва плодного пузыря является крайне важным мероприятием, так как при целых водах раскрытие шейки будет происходить более физиологично и чем позже произойдет разрыв оболочек, тем больше будет открытие зева и возможность для быстрого родоразрешения шире, чем при недостаточном раскрытии шейки.

При полном раскрытии производится разрыв пузыря, поворот на ножку и извлечение плода.

**В с л у ч а е г о л о в н ы х п р е д л е ж а н и й** при подвижной головке плода (если воды только что отошли) и достаточном открытии зева производят поворот на ножку и извлечение.

Если головка находится в полости таза и открытие полное, прибегают к наложению щипцов.

Если головка находится в выходе таза, применяют перинеото-мию, бинт Вербова или выходные щипцы.

При недостаточном открытии шейки матки и отошедших водах вводят метрейринтер, а в некоторых случаях делают кесарево сечение, ■..

**В с л у ч а е т а з о в ы х п р е д л е ж а н и й** при паличии полного открытия делают извлечение плода, при неполном открытии — извлечение ножки; извлечение производят только при полном открытии.

**В с л у ч а е п о п е р е ч н о г о п о л о ж е н и я** при наличии необходимых условий производят поворот на ножку независимо от того, имеют ли дело с живым или мертвым плодом. При живом плоде в случае полного открытия наружного зева делают поворот с последующим извлечением плода.

При недостаточном открытии: а) при целых водах ждут полного открытия, а затем делают поворот и извлечение плода; б) при отошедших водах вводят метрейринтер; одновременно срочно вызывают врача;

**ДВОЙНИ (GEMEELI).** Многоплодная беременность является следствием оплодотворения одновременно двух яйцеклеток или же разлития двух плодов из одной оплодотворенной яйцеклетки.

Различают однояйцевые и двуяйцевые двойни. В том случае, когда оплодотворена одна яйцеклетка, но вследствие деления опло-

дотворенного яйца на две самостоятельно растущие части развиваются два плода, говорят об однойцевой двойне. Однояйцевые близнецы имеют самостоятельные водные оболочки, но плацента и хорион у них общие. Однояйцевые близнецы всегда однополые и встречаются очень редко (в 15% случаев). Двухяйцевые близнецы встречаются чаще — в 85% случаев.

Двухяйцевая двойня развивается в результате оплодотворения двух яйцеклеток. В этом случае оба близнеца имеют отдельные самостоятельные плаценты, водную и ворсинчатую оболочку. В отличие от однойцевой двойни двухяйцевые двойни могут быть разнополыми.

Беременность при двойне протекает тяжелее, чем обычная беременность. При двойне чаще наблюдаются токсикозы беременности, чаще встречается отек беременных, а также эклампсия. Вследствие чрезмерного увеличения матки происходит высокое стояние диафрагмы, наблюдается затруднение дыхания и нарушение функции сердечно-сосудистой системы. В 25% случаев беременность двойней прерывается раньше срока.

**Показана** ранняя госпитализация беременных двойней.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Несоответствие между сроком беременности и величиной матки, т. е. матка прощупывается несколько выше, чем это соответствует сроку обычной беременности. Окружность живота больше, чем при обычной беременности! тех же сроков, на 10 см и более. При пальпации прощупывается не менее трех крупных частей плода и большое количество мелких частей.

Сердцебиение плода прослушивается четко в двух местах. Считать сердцебиение желательно одновременно двум лицам (врач и акушерка). Разница в частоте сердцебиения при одновременном подсчете двух выслушивающих около 15 ударов в минуту. Точный диагноз двойни во время беременности устанавливается путем рентгенологического исследования.

**В е д е н и е р о д о в .** При двойне часто наблюдается слабость родовой деятельности. Роды предоставляют их естественному течению; однако при длительно продолжающейся первичной родовой слабости в некоторых случаях рекомендуется произвести разрыв плодного пузыря, что допустимо при сглаженной шейке и открытии зева не менее чем на 2 пальца при продольном положении плодов.

После отхождения некоторого количества вод уменьшается напряжение и истончение маточных стенок и улучшается сократительная способность матки.

При разрыве плодного пузыря имеется опасность быстрого излития большого количества вод и выпадения мелких частей; поэтому плодный пузырь следует разрывать не в центре, а сбоку.

При разрыве плодного пузыря проверяют, нет ли выпадения мелких частей плода.

Во втором периоде родов при недостаточности потуг можно применить бинт Вербова,

Необходимо помнить, что после рождения первого плода следует перевязать плацентарный конец пуповины, во избежание кровотечения при однойцевой двойне (угроза гибели второго плода, находящегося еще в полости матки). После перевязки пуповины и оп-

ределения продольного положения второго плода торопиться с его извлечением без особых показаний не следует.

Необходимо следить за сердцебиением второго плода, предоставив роженице полный покой.

Если второй плод находится в поперечном или косом положении, то через полчаса после рождения первого плода следует разорвать плодный пузырь и произвести поворот на ножку второго плода с последующим его извлечением.

Ввиду того что при двойне матка подвергается значительному растяжению, могут иметь место осложнения в последовом периоде (задержка в отслойке и изгнании плаценты, гипотонические кровотечения — см.).

При недостаточном сокращении матки, наличии кровотечения необходимо применить сокращающие матку средства: питуикрин, маммофизин по 1 мл под кожу, лед на низ живота.

**ЖЕЛТАЯ ОСТРАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ (DYSTROPHIA HEPATIS ACUTA).** Желтуха во время беременности наблюдается при острых интоксикациях, когда последняя является сопутствующим заболеванием во время беременности, которая нередко осложняет течение инфекционного процесса.

Желтуха во время беременности наблюдается также при заболевании печени, печеночных камнях, холецистите. Однако желтуха во время беременности наблюдается и как самостоятельное заболевание, являющееся следствием аутоинтоксикации организма беременной (токсикоз беременности).

Желтуха при острой дистрофии печени является результатом тяжелой интоксикации продуктами неправильного обмена веществ во время беременности, одним из самых тяжелых токсикозов беременности.

Болезнь начинается с желтухи, которой иногда предшествует длительная тяжелая рвота; в дальнейшем болезненные явления нарастают: отмечается интенсивное окрашивание склеры и кожи, ухудшается общее состояние, затемняется сознание, появляется бред, возбужденное состояние, множественные кровоизлияния под кожу; в моче определяется лецитин, цирозин; количество мочи уменьшается, уменьшается и печеночная тупость. Ухудшение общего состояния больной быстро прогрессирует, смерть нередко наступает через несколько дней."

**Лечение.** При первых признаках желтухи беременную необходимо направить в стационар. В этих случаях показано вливание 5% раствора глюкозы под кожу 2 раза в день по 1 л, внутривенное вливание 40% раствора глюкозы по 150,0 три раза в день, введение инсулина по 10—15 единиц 2—3 раза в день, бессолевая диета, растительный стол.

При установлении диагноза желтой острой дистрофии печени показано прерывание беременности (по разрешению абортной комиссии).

**ЗАДЕРЖКА ЛОХИЙ (RETENTIO LOCHIORUM).** Задержка выделений в послеродовом периоде может быть обусловлена различными причинами, среди которых важнейшими являются механические затруднения оттока выделений (перегиб матки), а также воспа-

ление матки, недостаточное сокращение ее мускулатуры и тем самым плохое опорожнение содержимого матки.

**Симптомы.** Полное отсутствие или очень незначительное количество выделений, повышение температуры, иногда озноб, высокая температура в течение 2—3 дней подряд заставляют предположить послеродовое септическое заболевание.

**Лечение.** Назначение сокращающих матку средств: питуикрин, маммофизин внутримышечно по 1 мл в день. Лед на низ живота. Положение родильницы на животе (2—3 раза в сутки по 1—2 часа); сульфадiazин, сульфатiazол по 1 г 4 раза в день. При продолжающейся высокой температуре — лечение, как при эндометрите (см.).

**ЗАДЕРЖКА ПЛАЦЕНТЫ ИЛИ ЧАСТИ ЕЕ.** После рождения ребенка начинается последовый период, который продолжается до рождения (выделения) плаценты (детского места). Если нет кровотечения, спешить с выделением последа *а*" следует и можно спокойно ждать 1 — 173 часа. Незначительные кровянистые выделения в последовом периоде также не являются показанием к вмешательству. Однако если кровянистые выделения усиливаются и создается угроза значительной кровопотери (гипотоническое кровотечение), необходимо приступить к выделению плаценты (физиологическая потеря крови в последовом периоде не должна превышать 200—400 мл).

**Лечение.** Выжимание последа производят, соблюдая следующие правила: 1) мочевого пузыря опорожняют при помощи катетера; 2) матку выводят на среднюю линию; 3) производят массаж матки через брюшные стенки до тех пор, пока она равномерно хорошо сократится. Только после этого начинается выжимание плаценты. Для этого большой палец правой руки кладут на переднюю стенку матки, а четыре остальных пальца заводят через брюшные покровы на заднюю стенку матки; затем плавно, равномерно производят выжимание последа. Если роженица беспокойна — очень болезненно реагирует на выжимание последа, напрягает брюшные стенки и манипуляция остается неэффективной, — производят выжимание последа под наркозом, соблюдая указанные выше правила.

Если выжимание последа под наркозом не удастся, особенно при продолжающемся интенсивном кровотечении, производят ручное отделение и выделение последа.

Руки моют, как перед серьезной хирургической операцией, и обрабатывают спиртом и иодом; производят дезинфекцию наружных половых органов роженицы (спиртом и иодом). Все это должно быть сделано быстро во избежание сильной кровопотери.

Правую руку с конусовидно сложенными пальцами вводят в матку, там расправляют руку и «пилящими» движениями отделяют плаценту от стенки матки. Левая рука в это время фиксирует дно матки. После того как вся плацента отделена, проверяют, не осталось ли отдельных кусочков, и затем ее выделяют наружу.

Внутримышечно (в ягодицу) вводят 1 мл питуикрина или маммофизина, на низ живота кладут лед.

Родильница остается в родильной комнате не менее 3—4 часов под строгим наблюдением акушерки (возможность атонического

кровотечения после отхождения последа! см. *Атонические* — *гипотонические* — кровотечения).

**ЗАНОС КРОВЯНОМ** см. *Аборт*.

**ЗАНОС МЯСИСТЫЙ** см. *Аборт*.

**ЗАНОС ПУЗЫРНЫЙ** (MOLA HYDATIDOSA). Заболевание ворсинчатой оболочки плодного яйца с образованием пузырькообразных расширений, наполненных светлой жидкостью.

Перерождение ворсинок может быть полным или частичным и возникает в самой ранней стадии беременности. Иногда перерождение наступает, когда уже образовалась плацента, причем изменению подвергается вся плацента- или же часть ее (полный или частичный пузырьный занос). Плод обычно быстро погибает.

При частичном пузырьном заносе не исключена возможность сохранения живого плода.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Беременность в первые месяцы может протекать нормально. В дальнейшем появляются кровянистые выделения. Величина матки значительно больше размера, соответствующего данному сроку беременности, вследствие значительного разрастания пузырьного заноса. Консистенция матки дряблая, пастозная.

Появляется тошнота, рвота, иногда отек; в моче определяется белок.

С развитием беременности сердцебиение плода не прослушивается, беременная не ощущает его шевеления, не прощупываются отдельные части плода.

Кровотечение сопровождается выделением характерных пузырьков. Реакция Ашгейм-Цондска резко положительная.

Появление в выделениях пузырьков служит достоверным признаком пузырьного заноса.

**О п а с н о с т ь п у з ы р н о г о з а н о с а.** Длительные кровотечения, прорастание стенок матки и возможность их прободения при удалении заноса, возможность присоединения инфекции.

Основной опасностью является возможность образования после пузырьного заноса злокачественной опухоли — хорионэпителиомы.

**Л е ч е н и е.** При подозрении на пузырьный занос требуется госпитализация.

Если нет угрожающих кровотечений, проводят наблюдение за больной, выжидая самостоятельного опорожнения матки.

При значительных кровотечениях и достаточном открытии шейки прибегают к осторожному пальцевому удалению пузырьного заноса.

При угрожающем жизни кровотечении в исключительных случаях прибегают к бережному и чрезвычайно осторожному выскабливанию матки (опасность прободения!).

В случае самостоятельного выхода пузырьного заноса необходимо назначить сокращающие средства (питуикрин, маммофизин), произвести проверочное выскабливание для того, чтобы удалить самые незначительные остатки пузырьного заноса, так как оставление их угрожает в дальнейшем возможностью образования хорионэпителиомы.

После удаления пузырьного заноса больная находится под наблюдением консультации в течение 1—2 лет.

Больная должна вести точные записи менструальных циклов и каждые 3 месяца делать анализ мочи на реакцию Ашгейм-Цондска. В случае положительной реакции производят анализ на ту же реакцию, но с разведением, так как при хорионэпителиоме выделяется огромное количество хориального гонадотропного гормона, который обнаруживается даже в разведении 1:10, 1:50 и больше.

**НЕУКРОТИМАЯ РВОТА БЕРЕМЕННЫХ** см. *Рвота беременных*.

**НЕФРОПАТИЯ БЕРЕМЕННЫХ** (NEPHROPATHY GRAVIDARUM). Так называемая «почка беременных» — заболевание, связанное с беременностью, является следствием интоксикации продуктами неправильного обмена веществ; при этом в эпителии почечных канальцев происходят изменения характера перерождения; воспалительные изменения в почках при этом отсутствуют.

Нефропатия чаще встречается при первой беременности.

**С и м п т о м ы.** В моче определяется белок, появляются гиалиновые и зернистые цилиндры, уменьшается диурез. В некоторых случаях определяются увеличивающиеся отеки, нарастание веса беременной, повышение кровяного давления. Самочувствие значительно ухудшается: наступают головные боли, тошнота. Быстрое нарастание количества белка и цилиндров в моче; увеличение веса (свыше 300 г в неделю), быстро нарастающие отеки являются плохими прогностическими признаками — переход нефропатии в эклампсию (см.).

Медицинский персонал обязан тщательно и систематически наблюдать каждую беременную. При каждом посещении беременной консультации необходимо, помимо общего обследования, произвести три специальных исследования: 1) взвешивание (на предмет определения так называемых скрытых отеков); 2) анализ мочи (определение белка); 3) измерение кровяного давления. При этих исследованиях, а также при систематическом наблюдении за общим состоянием всего организма беременной в целом можно выявить раннюю стадию нефропатии и провести рациональное лечение.

**Л е ч е н и е.** Постельный режим (предпочтительнее госпитализация), молочно-растительная диета с ограничением поваренной соли до 3—4 г в сутки. Внутримышечно 20—25 мл 25% раствора сернокислой магнезии 3 раза в сутки в течение 6—8 дней; внутрь — сернокислая магнезия 15—20 г как слабительное (выведение части жидкости через кишечник). В более тяжелых случаях назначают фруктовые (яблочные) или овощные дни (два раза в неделю), а в некоторых — и однодневное голодание раз в неделю.

При наличии в моче 0,8—1% белка обязательна госпитализация.

**ОБВИТИЕ ПУПОВИНЫ** наблюдается вокруг шеи, туловища, ножки или ручки плода. Особенно опасно тугое обвитие пуповины вокруг шеи.

После рождения головки пальцами проводят по шее плода до плеч для того, чтобы проверить, не обвилась ли пуповина вокруг шеи. Если имеет место обвитие, петлю пуповины осторожно снимают.

ют через головку. В случае если это не удастся или же когда пуповина туго натянута, па пуповину быстро накладывают два зажима и между ними ее перерезают.

**ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ<sup>1</sup>.** Обезболиванию подлежат случаи нормальных срочных родов у здоровых рожениц. Роженица при поступлении в родильный дом должна быть тщательно обследована (рост, вес, размеры таза, состояние сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и пр.). Подготовку к обезболиванию необходимо начать еще в женской консультации (лекции, беседы). С этой же целью с момента поступления роженицы в стационар необходимо проявить к ней исключительно внимательное и чуткое отношение.

Обезболивание родов начинается с периода раскрытия шейки матки при условии наличия выраженных болей и хорошо развивающейся ритмической родовой деятельности (что обычно совпадает у первородящих с открытием зева на 2 пальца). До начала обезболивания необходимо осмотреть роженицу, обратив внимание на состояние сердечно-сосудистой системы, легких, почек (анализ мочи), печени и желудочно-кишечного тракта, а также на наличие лихорадочных заболеваний (грипп, ангина). При обследовании родовых путей обращают внимание на открытие зева (наружное исследование и исследование через прямую кишку), размеры таза, целостность или отхождение вод, при исследовании состояния плода — на доношенность, движение, сердцебиение плода (число ударов и ритм), положение и предлежащую часть.

Необходимо иметь точное представление и о характере родовой деятельности.

Акушерка должна тщательно наблюдать за общим состоянием роженицы (пульс, дыхание), за сердцебиением плода, характером родовой деятельности и за ходом обезболивания. Сердцебиение плода необходимо проверять возможно чаще (через каждые 15 минут), особенно после отхождения вод. В случае обнаружения каких-либо отклонений в сердцебиении (учащение, урежение) плода, а также явного ослабления родовой деятельности или патологических изменений в общем состоянии роженицы дальнейшее обезболивание немедленно прекращают.

Все данные осмотра роженицы перед поступлением в стационар и перед началом обезболивания, а также весь ход обезболивания записывают в историю болезни.

Учет результатов обезболивания родов: 1) случаи, когда роды с момента применения обезболивающего средства (начала действия его) до конца прошли совершенно безболезненно, обозначают тремя плюсами (-|—B +) — полное обезболивание; 2) случаи, когда роды с момента применения обезболивающего средства (начала его действия) до конца прошли при пониженной болевой чувствительности или полном отсутствии болей в течение некоторого времени (примерно 3 часа), обозначают двумя плюсами (-f- -f-) — частичное обезболивание; 3) слабый эффект обезболивания обозначают одним плюсом (+); 4) случаи, когда роды с момента применения

<sup>1</sup> Составлено применительно к инструкции Министерства здравоохранения СССР 1950 г.

а<

обезболивающего средства до конца прошли без понижения болевой чувствительности, обозначают минусом (—) — отрицательный результат обезболивания.

Все необходимые обезболивающие средства хранят в особом шкафу под замком в родильной или предродильной комнате, причем наличие в нем других, не относящихся к обезболиванию средств или предметов строго воспрещается. В шкафу хранится точная опись средств, применяющихся для обезболивания, и передаточная тетрадь, в которой учитывается поступление и расход обезболивающих средств.

**Перечень и техника применения медикаментозных\* средств, рекомендуемых для обезболивания родов в условиях родильных учреждений, где нет дежурного врача, но может быть быстро обеспечена врачебная помощь.**

а) **Начало периода раскрытия.** Применяется одно из следующих средств:

1. Свечи:

Rp. Extr. Belladonnae 0,02 Pantoponi 0,02  
Antipyrini 0,3 But. Cacao 1,5 M. f.  
Supp. S. По 1 свече в прямую кишку

**Техника применения.** На руку надевают резиновую перчатку или обматывают палец вощаной бумагой и вводят свечу обычным путем как можно глубже в прямую кишку.

**Примечание.** Повторное введение свечей одного и того же состава не рекомендуется.

2. Раствор пантопона п сернокислой магнезии:

Rp. Sol. Pantoponi 2% 1,0  
Sol. Magnesia sulfuric 20% 5,0 S. Для внутримышечного введения

**Техника применения.** Раствор вводят одним шприцем внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодичной области. Необходимо учитывать, что пантопон не следует применять позже чем за 2 часа до предполагаемого окончания родов. Препарат вводит акушерка в присутствии врача.

б) **Конец периода раскрытия** (открытие зева более чем на 3 пальца) и **период изгнания.**

1. Ликер на один прием:

Rp. Papaverini  
Extr. Belladonnae aa 0,02 Spiritus  
Vim 15,0 Sirupus simplicis 20,0  
MDS. Ликер на один прием

2. Ментоловый карандаш Кипарского: ментола 20%, парафина 80%.

Техника применения. Карандашом смазывают кожные покровы крестцовой и поясничной области и нижний отдел передней брюшной стенки.

в) Момент врезывания. Роженице через маску дают малые дозы эфира, пока она не успокоится, т. е. пока не будет достигнута поверхностная анестезия; после этого эфир продолжают давать только в начале каждой потуги, чем и поддерживается у нее дремотное состояние. Во время паузы наркоз прекращают.

Наркоз проводит врач или акушерка в присутствии врача. На роженицу затрачивают в среднем до 15—20 г эфира.

Перечень и техника применения медикаментозных средств, разрешаемых для обезболивания родов в условиях родильного дома, не имеющего дежурного врача (колхозный родильный дом) и обслуживаемого акушеркой

А. Период открытия

1. Свечи:

Rp. Extr. Belladonnae 0,015  
Pantoponi 0,02 Aspirini 0,5  
But. Cacao 1,5 MDS. Свечи

Примечания. 1. Аспирин может быть заменен в этой же дозировке фенацетином.

2. В случае необходимости введение свечи можно повторить, но не ранее чем через 2 часа после введения предыдущей свечи (не более одного раза).

2. Антипирин. Внутрь по 0,5 г, повторение при надобности, прием через 2 часа (не более одного раза).

В. Период изгнания. \*

Ментоловый карандаш Кипарского.

В. Момент врезывания и прорезывания.

Ликер:

Rp. Papaverini  
Extr. Belladonnae aa 0,02 Spiritus  
Vini 15,0 Simpus simplicis 20,0  
MDS. Ликер на один прием

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ см. *Психопрофилактический метод обезболивания родов.*

ОТЕК БЕРЕМЕННЫХ см. *Водянка беременных.*

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ ПОЛИП см. *Аборт.*

ПОВОРОТ ПЛОДА (VERSIO FOETUS). Различают наружный и внутренний поворот плода. Поворот производят из поперечного или косого положения в продольное

Показаниями к повороту являются: поперечное или косое положение плода, а также при некоторых случаях предлежания плаценты, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (при наличии условий для извлечения плода), при некоторых неблагоприятных вариантах головного предлежания (лобный, задний вид лицевого предлежания, высокое прямое стояние головки).

Наружный поворот при поперечном положении плода. Перевести плод из поперечного в продольное положение наружными приемами удастся только при значительной подвижности плода. Наружный поворот производится в стационаре (родильном доме) без наркоза. Мочевой пузырь и кишечник должны быть предварительно опорожнены. Поворот производится бережно, без насилия. Поворот должен быть безболезненным; ощущение боли является противопоказанием к продолжению производства поворота.

При малейшем подозрении на предлежание или низкое прикрепление детского места наружный поворот противопоказан.

Техника производства наружного поворота. Беременную укладывают на кушетку или кровать. Точно определяют, где находится головка и ягодицы плода. При косом положении плода беременную укладывают на тот бок, куда обращена предлежащая часть, вследствие чего последняя становится ближе ко входу в таз. Одной рукой стараются свести головку кпизу, а другой отодвигают ягодицы кверху, т. е. в противоположном направлении. Если ко входу ближе расположены ягодицы, легче низвести ягодичный конец плода, а головку перевести в противонролож-ную сторону<sup>1</sup>, т. е. ко дну матки.

Наружный поворот рекомендуется производить па последнем месяце беременности, так как в более ранние месяцы беременности плод может опять принять поперечное или косое положение.

Во время и после поворота необходимо тщательно прослушать сердцебиение плода.

Для сохранения продольного положения плода- рекомендуется с обеих сторон матки положить два валика, скатанных из пеленок или из мягкой материи, и забинтовать живот широким бинтом или длинным полотенцем.

Если изменить положение плода не удастся, беременная должна быть заблаговременно направлена в родильный дом (за 10—15 дней до предполагаемых родов); ко времени полного открытия плод переводят пут(\*i внутреннего поворота (поворот на ножку) из поперечного или косого положения в продольное.

Условия для производства поворота на ножку. Необходимыми условиями для производства операции поворота на ножку являются: 1) полное или почти полное открытие зева для того, чтобы можно было ввести руку в полость матки и в случае необходимости, закончив поворот, произвести извлечение плода; 2) достаточная подвижность плода в матке; 3) целостность плодного пузыря или же недавнее (1—2 часа) отхождение вод; 4) соответствие размеров плода размерам таза матери.

Техника операции поворота, на ножку при поперечном и косом положении плода.

Операция производится под общим наркозом. Роженица укладывается на поперечную кровать; опорожняется мочевой пузырь; тщательно дезинфицируются руки производящего операцию поворота (как перед большим хирургическим вмешательством), наружные половые органы роженицы обрабатываются спиртом и иодом.

Сложив конусообразно пальцы, руку вводят во влагалище и доводят до шейки. Если открытие зева достаточное и воды целы, разрывают плодный пузырь и быстро входят в полость плодного яйца, стремясь удержать возможно больше околоплодных вод и тем самым сохранить большую подвижность плода в матке.

Если воды прошли и выпали мелкие части (ручка или петля пуповины), выпавшую ручку не следует вправлять, так как при проведении операции поворота она отойдет вверх.

Что касается выпавшей петли пуповины, то ее нужно захватить с собой при введении руки в матку и дальше производить поворот, согласно общим правилам.

После введения руки во влагалище другую руку кладут на дно матки. Рукой, введенной в матку (внутренняя рука), проводят по туловищу плода, спускаясь до ягодиц, а затем, скользя по бедру и голени, захватывают указательным и средним пальцем стопу в области голеностопного сустава. Расположив наружную руку соответственно внутренней, помогают последней.

Как только будет захвачена стопа, ее низводят за маточный зев, наружной же рукой придвигают ягодицу книзу. При выведении ножки во влагалище наружной рукой отодвигают головку вверх, ко дну матки, одновременно извлекая внутреннюю руку" вместе с ножкой наружу.

Поворот считается законченным, когда из половой щели выйдет колено. По окончании поворота наружная рука прощупывает головку в дне матки.

Если имеется полное открытие шейки, приступают к извлечению плода.

Извлечение плода при неполном открытии зева противопоказано, так как при этом может произойти тяжелое осложнение — разрыв шейки матки.

Техника поворота на ножку при головных положениях. После тщательного "мытья рук и обработки их спиртом и иодом и соответствующей дезинфекции наружных половых органов роженицы вводят руку во влагалище, вскрывают плодный пузырь и отталкивают головку плода вверх и в сторону. Внутренняя рука скользит по туловищу плода, направляется к его ножке, захватывает стопу; поворот производится в соответствии с теми правилами, которые были изложены при описании техники поворота на ножку при поперечном или косом положении плода.

**ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА КОСое** см. *Положения плода поперечные и косые*.

**ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА ПОПЕРЕЧНЫЕ И КОСЫЕ.** Причиной является увеличение подвижности плода в полости матки, многоводие, растяжение стенок матки; встречается чаще у повторнородящих, главным образом у многоплодных; при двойне часто один плод

»

располагается продольно, а другой — в поперечном или косом положении.

Поперечные и косые положения плода встречаются также при неправильной форме матки, опухолях в области нижнего сегмента матки, в некоторых случаях предлежащая детского места, при узком тазе, когда головка не может установиться во входе и отклоняется в сторону}?

**Р а с п о з н а в а н и е.** Неправильная форма живота и матки (растяжение в поперечном или косом положении). Высота стояния дна матки несколько ниже, чем при продольном положении плода в тот же срок беременности; предлежащая часть плода над лоном не определяется; плотная круглая, ballotирующая головка плода определяется справа или слева на уровне пупка, чаще в одной из подвздошных областей. Сердцебиение плода прослушивается на уровне пупка, на той стороне, где расположена головка.

Уточнить диагноз можно путем внутреннего исследования, а также путем рентгенографии.

**Л е ч е н и е.** При распознавании поперечного или косого положения в консультации для беременных можно попытаться сделать наружный поворот (см.) и перевести плод в продольное положение.

Наружный поворот целесообразно произвести в конце беременности (на X лунном месяце), так как поворот в более ранние сроки беременности не является устойчивым, и плод может принять свое прежнее (поперечное или косое) положение.

При косом положении плода, когда роженица находится уже в стационаре, ее кладут на тот бок, в сторону которого отклонена предлежащая часть.

При достаточной подвижности плода в полости матки нижнюю часть плода (головку или ягодицы) передвигают в сторону входа в таз.

Если плод расположен поперечно, при целых водах и достаточной его подвижности нужно попытаться очень осторожно произвести наружный профилактический поворот, ни а коей мере не форсируя перевод плода в продольное положение. Если попытка не удалась, нужно оставить роженицу в покое, чтобы не вызвать преждевременного отхождения околоплодных вод.

При поперечном или косом положении «заслонка» между передними и задними водами отсутствует (роль «заслонки» выполняет при продольном положении головка или ягодицы плода). Поэтому отхождение вод может произойти значительно раньше, чем закончится первый период родов, т. е. полное раскрытие шейки матки. При целых водах и полном раскрытии шейки надо разорвать пузырь и сделать поворот на ножку.

То же самое можно сделать в случае недавно отошедших вод (час назад) при условии достаточной подвижности плода.

При отошедших водах и недостаточном раскрытии шейки матки применяют введение метрейринтера; как только родился метрей-риптер, производят поворот на ножку.

При давно отошедших водах операция поворота противопоказана (опасность разрыва матки).

Ври запущенных поперечных положениях прибегают к эмбриотомии (производится только врачом).

После Операции в течение 2—3 дней применяют введение пенициллина по 50 000—100 000 единиц через 3 часа и назначают сульфаниламидные препараты по 1,0 три-четыре раза в день.

**ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД** — время от окончания родов до полного обратного развития половых органов женщины. Этот период продолжается обычно около 6 недель. После родов (после отхождения плаценты) женщина испытывает усталость, а иногда некоторую сонливость. Женщина должна находиться в родильной комнате не менее 3—4 часов после родов. Если нет кровотечения и самочувствие родильницы удовлетворительно, она переводится в послеродовое отделение.

Непосредственно после родов дно матки прощупывается на один-два пальца ниже пупка, в первый день после родов — на уровне пупка, а иногда на 1—1½ пальца выше пупка. Матка весьма подвижна, так как связочный аппарат растянут, поэтому она легко отклоняется вправо, влево или кзади. Вследствие этого родильница не должна лежать долго на одном боку или на спине. Переполненный мочевой пузырь также мешает нормальному сокращению матки. Нужно помнить, что каждые 100 мл мочи поднимают матку на 1 см.

На 3-й день послеродового периода при нормальном его течении и хорошей сократительной способности матки дно ее прощупывается на один-два пальца ниже пупка, на 4-й день — на три пальца ниже пупка, на 5-й — по середине между пупком и лобком, на 7-й — матка прощупывается над лонным сочленением, а к 10-му дню дно ее должно стоять не выше одного пальца над лонным сочленением.

В то же время формируется и шейка (постепенно сокращается), и ее капал. Формирование шейки в нормальных условиях заканчивается к 10-му дню после родов.

Плохое сокращение матки указывает на недостаточную сократительную ее способность, которая в большинстве случаев вызывается инфекционным процессом, реже наличием фибромиомы? персрастяжением матки во время беременности (многоводие, многоплодие) и пр.

Необходимо ежедневно измерять высоту стояния дна матки после родов и отмечать количество и качество послеродовых выделений из матки (лохий). В первые 3—4 дня обычно отмечаются кровянистые выделения, следующие 3—4 дня — кровянисто-серозные и, наконец, через 7—8 дней после родов выделения должны быть без примеси крови. Наличие кровянистых выделений позже 7—8-го дня после родов говорит о патологическом состоянии родильницы (плохое сокращение матки, наличие остатков плацентарной ткани, воспалительный процесс и т. п.). Точно так же патологическим нужно считать наличие в выделениях гноя.

Температуру после родов надо измерять 2—3 раза в день; в это время она не должна быть выше 36,8—37°. При нормальном течении послеродового периода можно отметить два повышения температуры: первое — через 12 часов после родов и второе — на 3—4-е сутки после родов, однако эти повышения должны находиться в

пределах 37,5° и должны быть однократными. В противном случае необходимо принять ряд профилактических и лечебных мер для борьбы с инфекционным процессом (назначение сульфаниламидных препаратов, введение пенициллина).

Пulse после родов обычно замедлен. Учащение пульса даже при нормальной температуре (расхождение между пульсом и температурой) нередко является одним из ранних симптомов начинающегося септического процесса, особенно тромбоза.

После родов довольно часто отмечается ишурия (задержка мочеиспускания). Для опорожнения мочевого пузыря рекомендуется инъекция под кожу 1-0 мл 25% раствора сернокислой магнезии или внутривенное введение 5—8 мл 40% раствора уротропина. Если эти мероприятия не помогают, необходимо произвести катетеризацию мочевого пузыря, которую производят два раза в сутки — утром и вечером, соблюдая все правила асептики, так как женщина в послеродовом периоде весьма восприимчива к инфекции вообще и в частности к инфицированию мочевых путей.

После родов отмечается вялость кишечника и в огромном большинстве случаев не происходит самостоятельного его опорожнения. На третьи сутки обычно дают слабительное, лучше всего касторовое масло.

Не менее двух раз в день производят так называемую уборку родильницы: наружные половые органы обмывают кипяченой водой или слабым раствором борной кислоты (из кувшина поливают на наружные половые органы сверху вниз и спереди кзади; при этом женщина находится в лежачем положении и иод ее ягодицы подставляют подкладное судно). Уборку производят стерильной марлей (или ватой) с помощью стерильного корнцанга. Инструменты меняют при уборке каждой родильницы.

Необходимо тщательно следить за состоянием грудных желез. Перед каждым кормлением и после него соски обмывают слабым раствором борной кислоты и насухо вытирают. После кормления на соски накладывают кусок стерильной марли, смоченной в стерильном вазелиновом масле. Кормление грудью производится в масках во избежание передачи новорожденному возможной у матери инфекции (гриппа).

Уже на вторые сутки после родов родильнице можно разрешить легкие движения, даже лечебную физкультуру, выполняемую под наблюдением прача или инструктора физкультуры. Первые три дня родильница производит все эти движения в лежачем положении, а начиная с 4—5-го дня, она может выполнять соответствующие упражнения стоя на полу.

Обычно родильнице в случае нормального течения послеродового периода разрешается встать на седьмые сутки, но выписка из родильного дома может быть разрешена не ранее восьми полных суток после родов даже при нормальном течении послеродового периода.

**ПОЧКА БЕРЕМЕННЫХ** см. *Нефропатия беременных*.  
**ПРЕДЛЕЖАНИЕ ДЕТСКОГО МЕСТА — ПЛАЦЕНТЫ (PLACENTA PRAEVIA)**. Если плацента прикреплена в нижней части матки непосредственно над внутренним зевом или сбоку от него,

она оказывается предлежащей частью плодного яйца; в таком случае детское место расположено ниже предлежащей части плода (головки или ягодицы).

Причинами, способствующими предлежанию плаценты, является — ей воспаление матки, наличие подслизистых миоматозных узлов, аномалии развития плодного яйца.

Формы предлежания детского места в зависимости от положения его по отношению к внутреннему зеву: 1) к р а е в о е предлежание детского места (при открытии зева на  $1\frac{1}{2}$ —2 пальца прощупывается крап плаценты, а с. другой стороны — плодный пузырь); 2) б о и т о в о е предлежание детского места (плацента расположена над внутренним зевом только своей боковой частью); 3) ц е н т р а л ь н о е предлежание детского места (плацента покрывает внутренний зев и расположена над ним своим центром).

Р а с п о з н а в а н и е и т е ч е н и е. Основным симптомом являются маточные кровотечения, в одних случаях интенсивные, в других незначительные, а иногда только «мажущие».

Кровотечения при предлежании детского места обычно наступают в последние два-три месяца беременности, непосредственно перед родами и во время родов.

Причиной кровотечения является отслойка детского места и разрыв кровеносных сосудов.

Не всегда интенсивные кровотечения зависят от формы предлежания детского места. Иногда краевое предлежание может сопровождаться более сильным кровотечением, чем боковое предлежание.

Диагноз ставится на основании повторных кровотечений в конце беременности. При отсутствии родовой деятельности диагноз уточняют путем внутреннего исследования, которое надо производить очень бережно.

Если шейка раскрыта, прощупывается тестоватая консистенция ткани плаценты, которая расположена непосредственно над зевом или сбоку от него. Всякое насильственное проведение пальца вглубь матки сопровождается кровотечением.

Для установления диагноза предлежания плаценты в конце беременности можно применить рентгенологический метод.

Л е ч е н и е. При подозрении на предлежание детского места больную необходимо немедленно госпитализировать.

При ведении родов, осложненных предлежанием детского места, следует руководствоваться двумя моментами: 1) силой, интенсивностью кровотечения и 2) состоянием родовых путей.

Если кровянистые выделения незначительны, беременная укладывается в постель и за ней устанавливают тщательное наблюдение, уделяя особое внимание интенсивности кровотечения. Даже при незначительном кровотечении необходимо 3—4 раза в день измерять кровяное давление.

Если роды уже начались, при незначительном кровотечении, хороню выраженной родовой деятельности, боковом предлежании детского места и при раскрытии шейки не менее чем на два пальца разрывают плодный пузырь. После излития вод головка опускается и тем самым прижимает плаценту. Кровотечение приостанавливается, и роды обычно заканчиваются нормально.

При раскрытии шейки на 3—4 пальца производится поворот на ножку и ее низведение.

Форсировать извлечение плода, в особенности при неполном раскрытии зева, не следует, так как нижний маточный сегмент, где прикреплена плацента, весьма истончен и форсированное родоразрешение может повлечь за собой разрыв матки.

При недостаточном раскрытии зева ( $2\frac{1}{2}$ —3 пальца) надо ввести метрейринтер; при этом метрейринтер прижимает плацентарную площадку, и кровотечение приостанавливается; ждут рождения метрейринтера или раскрытия до  $3\frac{1}{2}$ —4 пальцев, после чего делают поворот на ножку.

При боковом или краевом предлежании детского места, незначительных кровотечениях и недостаточном раскрытии накладывают кожно-головные щипцы по Иванову.

В случае интенсивного кровотечения и отсутствия условий для быстрого родоразрешения вагинальным путем (раскрытие зева на  $1\frac{1}{2}$ —2 пальца) производят кесарево сечение.

Наложение щипцов при предлежании детского места категорически противопоказано.

В случае необходимости транспортировать больную в родовспомогательное учреждение при значительном кровотечении необходимо туго затампонировать влагалище стерильным марлевым бинтом и ввести под кожу 1 мл 2% морфина с целью снизить интенсивность маточных сокращений и для профилактики дальнейшей отслойки детского места и кровотечения.

#### ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА ГОЛОВНЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ.

Единственно нормальным биомеханизмом родов считают ту сумму последовательных движений головки и туловища плода, которые происходят во время родов при переднем виде затылочного предлежания (затылок впереди). В случае же, когда спинка и головка обращены кзади, биомеханизм родов проходит не типично, а с некоторым отклонением от нормального биомеханизма. При этом затылок поворачивается кзади, к крестцовой впадине; во входе в таз стреловидный шов стоит в поперечном размере, в полости таза — в косом, а на дне — в прямом размере.

При левой позиции плода стреловидный шов в полости таза совпадает с левым косым размером таза (одноименным с позицией), при второй (правой) позиции — с правым косым размером полости таза (также одноименным).

Б и о м е х а н и з м р о д о в п р и з а д н е м в и д е з а т ы л о ч н о г о п р е д л е ж а н и я. Проводной точкой является условно большой родничок. При описываемом механизме имеется две точки фиксации (опоры) головки: первая для усиления сгибания головки и вторая для разгибания ее. Когда передняя часть головки доходит до границы волосистой части лба, она, упирается здесь в нижний крап лонной кости, делает сгибание, вследствие чего со стороны промежности выкатывается затылок до подзатылочной ямки (сгибание); затем область подзатылочной ямки упирается в копчик (вторая точка фиксации), происходит разгибание головки, из-под симфиза выкатывается лобик, личико и подбородок.



Ведение родов при заднем виде затылочного предлежания должно быть строго выжидательным. К ускорению родоразрешения должны иметься строгие показания (асфиксия плода, ригидность тканей родовых путей, повышение температуры у роженицы и пр.).

#### Механизмы родов при разгибательных состояниях головки

а) **Переднее головное предлежание.** Распознавание. Легкая степень разгибания (подбородок несколько отходит от грудки); затылок и спинка, так же как и при заднем виде затылочного предлежания, обращены кзади. Головка плода выступает в таз стреловидным швом в поперечном (отчасти в косом) размере. При внутреннем повороте головки передняя часть ее поворачивается кпереди (вперед теменем) и в это же время опускается ниже; в полости таза стреловидный шов проходит через те же косые размеры, как и при заднем виде затылочного предлежания (в полости таза стреловидный шов стоит в одном из косых размеров, одноименных с позицией плода).

Биомеханизм прорезывания головки. В основном совпадает с таковым при заднем виде затылочного предлежания, но отличается от него тем, что проводная точка, точки фиксации и прорезывающаяся окружность головки будут иными.

Проводной точкой при переднем головном предлежании является нижне-передний край большого родничка. Точки фиксации: 1) переносье, надбровные дуги (glabella) и 2) затылочный бугор.

Во время прорезывания головки в первую очередь показывается большой родничок и лобик; затем головка прорезывается до тех пор, пока под симфизом не покажется переносье (первая точка опоры); при этом головка начинает сгибаться; через промежность выкатываются теменные бугры и затылок до затылочного бугра. Затылочный бугор упирается в область копчика (вторая точка фиксации), головка разгибается, из-под симфиза выкатывается личико и подбородок. Ведение родов при передне-головном предлежании должно быть строго выжидательным; оперативное вмешательство предпринимают только по строгим показаниям как со стороны матери, так и со стороны плода.

б) **Лобное предлежание.** Распознавание. При внутреннем исследовании прощупывается лобик и личико, стоящие над входом или з^же во входе в таз. Ясно прощупываются надбровные дуги и корень носа; до большого родничка дойти не удается.

Лобное предлежание иногда переходит в лицевое (при вставлении головки в таз разгибание усиливается, и, таким образом, лобное предлежание переходит в лицевое).

Биомеханизм прорезывания головки при лобном предлежании. Проводной точкой является корень носа. Точки фиксации две: верхняя челюсть и затылочный бугор. Таким образом, верхняя челюсть фиксируется под лонной дугой и через промежность выкатывается головка. Головка прорезывается значительной окружностью (35 см — соответствует большому косому размеру).

а»

Роды весьма длительные, прогноз для ребенка сомнительный. Осложнения. Частые разрывы промежности; асфиксия плода; образование пузырно-влагалищных свищей; разрывы матки.

Ведение родов должно быть выжидательным.

При наличии условий — поворот на ножку; при стоянии головки во входе в таз — перфорация.

в) **Лицевое предлежание.** В первый момент биомеханизма родов головка вместо сгибания делает разгибание (резко выраженная степень разгибательного типа). После окончания периода раскрытия головка вступает в таз не стреловидным швом, а лицевой линией (от лобного шва до подбородка).

Различают передний вид (когда подбородок повернут к симфизу) и задний вид (когда подбородок повернут к крестцу) лицевого предлежания.

Биомеханизм родов при переднем виде лицевого предлежания. Проводная точка — подбородок. Точка фиксации — область подъязычной кости. Прорезывающаяся окружность головки — 33 см. Первым показывается подбородок под симфизом. В процессе прорезывания головки личико доходит подъязычной областью до лонной дуги. Область подъязычной кости (точка фиксации) упирается в нижний край лонной дуги. Вокруг этой точки происходит сгибание головки. В черепе промежность выкатывается нос, лобик, темя и затылок.

Ведение родов выжидательное; тщательное наблюдение за динамикой родов, за роженицей; частое выслушивание сердцебиения плода.

Роды при заднем виде лицевого предлежания (личико повернуто подбородком кзади) абсолютно невозможны.

Если повторное исследование показывает, что подбородок не имеет тенденции повернуться кпереди, то при живом плоде в условиях стационара показано кесарево сечение.

В случае отсутствия соответствующих условий делают перфорацию.

Наложение щипцов строго противопоказано.

**ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА ТАЗОВЫЕ.** Различают ягодичные и ножные предлежания.

Среди ягодичных предлежаний различают чистые (ножки плода вытянуты по длине туловища, во вход таза вступают ягодички плода) и смешанные (ножки плода согнуты в коленно-тазобедренных суйтавах); вместе с ягодичками во вход в таз вступают и ступни.

При ножных предлежаниях предлежат обе ножки (полное поположение) или одна ножка.

Тазовое предлежание чаще встречается при родах двойней или преждевременных родах, многоводии, низком прикреплении или предлежании детского места, при чрезмерной растянутости стенок матки.

Распознавание. Над входом в таз прощупывается крупная мягковатая часть; предлежащая часть не баллотируется или слабо баллотируется. В дне матки прощупывается плотная круглая;

баллотирующая часть — головка. Сердцебиение плода ясно прослушивается над уровнем пупка или выше его.

В сомнительных случаях окончательный диагноз ставится на основании внутреннего исследования.

**В е д е н и е р о д о в .** Первый период родов (период раскрытия) необходимо проводить строго выжидательно, следить за сердцебиением плода, за опорожнением мочевого пузыря и характером родовой деятельности.

Второй период (период изгнания) проводят на поперечной кровати. Как только туловище вышло до пупочного кольца, на родившуюся часть плода накладывают теплую стерильную пеленку; большие пальцы кладут на крестец плода, остальными захватывают бедра спереди, а указательные пальцы кладут на гребешки подвздошных костей; все это продельвают осторожно и мягко с тем, чтобы не произвести давления на брюшные стенки плода и не повредить его внутренних органов, в особенности печень. Затем туловище ребенка поднимают вверх и в сторону; если ручка не была запрокинута, она при этом легко выпадает. После этого туловище плода поворачивают в сторону так, чтобы плечики, бывшие под симфизом, оказались внизу; при этом вторая ручка также легко выходит со стороны промежности.

После рождения ручек приступают к извлечению головки.

Нужно помнить, что с момента появления из половой щели нижнего угла лопатки наступает опасность асфиксии плода. Это объясняется тем, что в это время головка вступает во вход в таз и придавливает пуповину к стенкам костного кольца таза.

Если ведение родов при тазовом предлежании до момента появления нижнего угла лопатки из половой щели было выжидательным, то с этого момента все мероприятия акушерки должны быть быстрыми, так как промедление в ведении родов угрожает жизни плода.

После рождения ручек акушерка сажает младенца «верхом» на свое предплечье и вводит указательный палец руки в его ротик. Указательный и средний палец другой руки кладут по обе стороны шеи (виллообразно), на плечики младенца и спинку и равномерными движениями производят тракцию в направлении родовой оси таза.

**Ручное пособие при ягодичном предлежании по методу Цовьянова.** После того как родились ягодички и туловище плода прорезалось до пупочного кольца, ягодички поддерживают, чтобы они не свисали вследствие собственной тяжести. Для поддержания туловища плода ягодички охватывают так, чтобы большие пальцы обеих рук располагались по задней поверхности бедер, которые прижимаются к брюшной стенке; остальные четыре пальца обеих рук располагают на крестцовой поверхности плода. Прижимая бедра к брюшной стенке, тем самым сохраняют ножки вытянутыми по длине туловища плода, вследствие чего они не выходят раньше, чем выйдет весь плечевой пояс. При этом приеме предупреждается запрокидывание ручек, так как к моменту прохождения плечевого пояса ручки оказываются скрещенными на груди.

Головка при методе Цовьянова освобождается, как обычно (см. выше).

**ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДЕТСКОГО МЕСТА.** Плацента расположена на обычном месте; отслойка ее началась или произошла до рождения ребенка. Наиболее частые причины — короткая пуповина, травма, токсикозы беременности (альбинурия), некоторые инфекционные процессы, воспалительные заболевания слизистой оболочки матки и др.

Преждевременная отслойка детского места может быть частичной и полной. В первом случае кровотечение может быть незначительным.

При полной отслойке детского места нередко наблюдается значительное кровотечение, внезапная смерть плода, общее тяжелое состояние матери.

**Симптомы и течение.** Если при предлежании детского места кровотечение бывает наружным и часто облегчает постановку диагноза, то при преждевременной отслойке нормально прикрепленного детского места кровотечение часто бывает только внутренним (внутриматочным).

При подозрении на преждевременную отслойку детского места должны быть учтены все признаки внутреннего кровотечения (резкая бледность беременной, частый, слабый пульс, вздутие и болезненность живота). Матка напряжена, болезненна; отмечаются признаки раздражения брюшины (возможность излития части крови через трубы в брюшную полость).

**Лечение.** В условиях оборудованного стационара — кесарево сечение.

При наличии соответствующих условий (полное открытие, головка в полости или выходе) накладывают щипцы.

Если воды целы, открытие полное или приближается к полному, при подвижной головке делают поворот на ножку, производят извлечение плода и немедленное выделение плаценты.

При фиксированной глубоко во входе головке прибегают к перфорации, краниоклазии и немедленно извлекают плод.

Переливание крови; введение под кожу физиологического раствора или 5% раствора глюкозы.

Профилактически — пенициллин через 3 часа по 50 000 единиц; сульфаниламидные препараты (внутрь или в виде ректальных свечей) по 1 г четыре раза в день.

**ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ.** Прерывание беременности после 28 и до 39 недель.

**Причины:** тифы, воспаление легких, сифилис, малярия, заболевание почек, опухоли матки (фибромы), недоразвитие половых органов, особенно матки, воспалительные заболевания матки, придатков, нарушение функции желез внутренней секреции, заболевание плаценты, нервные потрясения и др.

**Признаки.** Схваткообразные боли внизу живота, боли в крестце, наличие кровянистых выделений.

**Течение.** Нередко наблюдаются осложнения: раннее отхождение вод, кровотечения; быстрые роды при неподготовленности

мягких родовых путей, разрывы шейки и промежности; задержка детского места. В таких случаях имеет место не только невыделение, но даже неотделение плаценты.

**Лечение.** При первых же явлениях наступающих преждевременных родов нужно направить беременную в родильный дом.

Необходимо приостановить начавшиеся сокращения матки. Полный физический и психический покой (холод и тепло на низ живота противопоказаны). Внутрь бромиды, опиаты, а при значительно выраженных схватках — наркотики.

Назначают T-гае Opii simplex по 8 капель 2—3 раза в день, бехтеревскую микстуру 3—4 раза в день по одной столовой ложке, порошки следующего состава:

Rp. Papaverini 0,02 Antipyrini 0,5  
Pyramidoni 0,3 M. f. pulv. D. t. d. N. 10  
DS. 3 раза в день по 1 порошку

или микстуры по следующей прописи:

Rp. Natrii Bromati 2,0 Antipyrini 2,0 Pyramidoni 1,0  
Coffeini natrio-benzoici 1,0 Aq. destill. 200,0  
MDS. 4 раза в день по 1 столовой ложке

или, наконец, 1% раствор пантопона 2 раза в день по 0,5 мл.

Хорошо действует прогестерон: первые три дня вводят подкожно по 1 мл (т. е. 5 мг прогестерона) 2 раза в день, а в последующие 7 дней — по одному разу. В случае отсутствия эффекта продолжают лечение прогестероном в течение 20—24 дней.

Одновременно выясняют причину (см. выше) преждевременных родов и проводят соответствующее лечение. При наличии кровянистых выделений не надо забывать о возможности преждевременной отслойки детского места или предложения плаценты.

**ПРЕЭКЛАМПСИЯ** см. *Эклампсия*.

**ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ.** Система психопрофилактики болей в родах построена на основе применения принципов и закономерностей учения И. П. Павлова.

Исходным положением при построении этой системы является признание необязательности родовой боли и ненужности ее для правильного течения родового акта.

Система психопрофилактики болей в родах является комплексной.

В этой системе придается большое значение правильному акушерскому ведению родов, предохраняющему от осложнений и отклонений, могущих вызвать боль.

i Согласно инструкции Министерства здравоохранения СССР 1951 г.

Основой психопрофилактической системы является дородовая подготовка женщины и правильное ведение родов. Важнейшим моментом дородовой подготовки является мероприятие по борьбе со страхом и отрицательными эмоциями и ознакомление женщины с течением нормальных родов как физиологического естественного акта, при котором опасности и страдания не являются неизбежными.

#### А. Организация и методика психопрофилактической подготовки беременных в консультации

Метод психопрофилактики болей в родах представляет собой единую систему. Часть мероприятий этой системы осуществляется в консультации, другая часть — в родильном стационаре. При этом в работе женской консультации особое значение приобретают формы активной профилактики (активное врачебное наблюдение беременной, патронаж, социально-правовая помощь, развернутая социально-просветительная работа).

Санитарно-просветительная работа проводится в двух направлениях: а) привлечение беременных к психопрофилактической подготовке, б) популяризация среди населения новых отношений к родам и к психопрофилактике болей в родах на основе учения И. П. Павлова.

Осуществление метода профилактики болей в родах начинается в женской консультации путем предварительной дородовой индивидуальной и групповой подготовки беременных.

Подготовка проводится или специально выделенным врачом (в особом кабинете), или участковым врачом (в его кабинете).

При выделении отдельного кабинета желательно оборудовать его несколькими мягкими кушетками и обеспечить тишину. Кабинет должен иметь обычное оборудование, необходимое для работы врача в женской консультации, и комплект наглядных пособий для занятий с беременными.

Метод профилактики болей в родах может быть применен при всякой нормально протекающей беременности. Наличие тазовых предлежаний, сердечно-сосудистых заболеваний, токсикозов беременности не служит противопоказанием. Истерия, психастения, эмоциональная лабильность также не служат противопоказанием к применению метода, так как психопрофилактическая подготовка создает эмоциональную устойчивость, необходимую для указанной группы беременных.

Для беременных, страдающих истерией, психастенией и психопатией, показано индивидуальное проведение психопрофилактической подготовки.

При тяжелых психических заболеваниях метод психопрофилактики болей не проводится.

В условиях села и колхозных родильных домов подготовку и ведение родов проводят акушерки, предварительно обученные этому методу.

В условиях района и села в некоторых случаях психопрофилактическая подготовка может быть проведена на дому (например, в период распутицы).

Психопрофилактическая подготовка беременных в консультации начинается с 36-й недели беременности. Схема предусматривает 5—6 занятий, проводимых через каждые 3—4 дня. Однако при необходимости подготовка может быть сокращена и до 3 занятий.

Каждое занятие состоит из трех частей.

Первая часть включает общесоматический и акушерский осмотр каждой беременной женщины и соответствующее назначение и наставление.

Вторая часть состоит из объяснения процесса родов и «приемов обезболивания» по этапам родов; эта часть подготовки беременных осуществляется при помощи педагогических приемов с учетом доступности материала по форме изложения для слушательниц, с использованием наглядных пособий и с применением практических занятий; женщина должна понять и осмыслить преподаваемые ей материалы.

Третьей части многократным повторением в состоянии покоя — отдыха закрепляются «приемы обезболивания».

Первое занятие проводится индивидуально и посвящается клиническому обследованию беременной (общесоматическому, акушерскому) и собиранию некоторых психоанамnestических данных. Проводится снятие страхов и опасений. При обследовании надо обратить внимание на возраст, образование, профессию, жизненный опыт беременной; установить наличие психических травм, если таковые имели место; вскрыть содержание опасений, а возможно, и страхов, которые могут иметь место в связи с ожидаемыми родами; выяснить не только содержание этих опасений, но и их источник и интенсивность.

Снятие страхов проводится для устранения возможности возникновения отрицательных эмоций и влияния их на силу болевых реакций. Устранить эмоции негативного тона и создать позитивные эмоции — существенная задача всей системы психопрофилактики болей в родах.

Для снятия выявленных опасений и страхов надлежит пользоваться различными формами доказательного опровержения.

Второе занятие рекомендуется проводить, как и все последующие, в порядке групповых занятий. Оно посвящается описанию родов как нормального физиологического акта. Разрушаются представления об обязательной болезненности родов, опровергаются основные житейские представления о причинах родовых болей.

Третье и четвертое занятия проводятся по первому периоду родов.

В этом занятии объясняются субъективные ощущения рожавшей женщины: дается представление о схватках и их регулярности; о зонах Снегирева как о кожных метамерах внутренних органов; преподаются механизм раскрытия как механизм бережный и не вызывающий боли и объясняются «приемы обезболивания» схваток. Эти приемы заключаются в следующем:

1) глубокие, ритмичные вдохи и выдохи на протяжении каждой схватки;

2) легкое поглаживание (почти прикосновение) нижней половины живота в сочетании с вдохом и выдохом; поглаживание осуществляется концами пальцев обеих рук; оно производится от средней линии живота кнаружи и в стороны, в виде физкультурного комплекса, сочетания Движения рук с ритмичным дыханием;

3) прижатие следующих точек: а) спереди у передне-верхних подвздошных остей; б) сзади у наружных углов поясничного ромба; при прижатии точек у передних остей ладони располагаются вдоль бедер, прижатие же совершается концами отставленных больших пальцев с легкой вибрацией их.

Прижатие точек у наружных углов поясничного ромба совершается либо подкладыванием кистей рук роженицы, сжатых в кулаки, либо подкладыванием валика.

Приемы должны выполняться тщательно и старательно.

Пятое занятие проводится по второму периоду родов.

В педагогической части объясняются субъективные ощущения, которые имеют место в начале второго периода родов и при развитии потужной деятельности. Дается объяснение значения правильных потуг в успехе проведения второго периода.

В качестве приемов обезболивания в этом периоде используется рациональная поза роженицы и правильное выполнение потужного напряжения.

Для обезболивания опосредствуется правильная поза с приподнятым плечевым поясом, твердо и правильно поставленными нижними конечностями и фиксированными руками.

Для обезболивания опосредствуется само потужное напряжение, которое рекомендуется совершать в три приема. Беременная тренируется на задержку дыхания приблизительно на протяжении 20 секунд и на смыкание голосовой щели при развитии потуги.

К моменту выведения головки, опосредствуется для обезболивания свободное дыхание со счетом на выдохе и расслаблением мышц верхних конечностей.

Шестое занятие является заключительным. Беременная, готовящаяся к родам, получает положительную эмоциональную установку, содержанием которой является «радость материнства». Материнство освещается как высокая и почетная гражданская задача женщины. Установленные правительственные награды за материнство и другие меры государственной заботы о женщине-матери неопровержимо доказывают это. Материнство освещается как большое событие в личной жизни, обогащающей новым и прекрасным содержанием.

В этом занятии дается положительная установка на родильный дом с изложением порядка приема. Беременная получает сведения об ожидающих ее манипуляциях, проводимых при приеме. Укачивается на необходимость доброжелательного контакта ее со всем медицинским персоналом; необходимость нормального питания, опорожнения мочевого пузыря и прямой кишки. Беременная осведомляется о возможных дополнительных лечебно-диагностических

мероприятиях (внутреннее исследование, ингаляция кислорода, вливание глюкозы и т. д.).

При наличии общемедицинской и психогигиенической культуры в родильном доме, при правильной постановке метода психопрофилактики болей в родах, при поступлении беременных и рожениц, не охваченных предварительной подготовкой, последняя проводится в самом родильном доме. Для этого необходимо:

- а) установить контакт с роженицей в процессе обследования;
- б) вскрыть опасения и страхи и устранить их рациональной беседой;
- в) обучить поведению в родах, используя все наличные возможности, в том числе демонстрацию поведения в родах женщин, прошедших подготовку, общение с успешно родившими, «передачу опыта» уже подготовленной роженицей вновь поступившей и неподготовленной.

Основные ошибки подготовки по методу психопрофилактики болей в родах могут быть сведены в такие группы:

- а) недостаточно глубокое изучение анамнеза;
- б) неправильные общие установки на характер ощущений в родах;
- в) недостаточная и неправильная подготовка;
- г) отсутствие должной психогигиенической культуры подготовляющего персонала.

#### Б. Организация и методика психопрофилактики родовых болей в стационаре родильного дома

• Создание должной обстановки в родильном отделении, что достигается наличием тишины и порядка, образцовым поведением персонала на психогигиенических основах, отсутствием посторонних разговоров,\* правильной сдачей дежурств и т. п. При этом необходимо создать органическую преемственность в работе кабинета подготовки (консультации) и родильного отделения на основах единства методики подготовки и методики ведения родов.\*

Работа по психопрофилактике болей в родах начинается с момента поступления роженицы в отделение и продолжается все время до окончания родов.

В смотровой следует обратить внимание на то, как реагирует роженица на начало родов — спокойна ли она, не оказывают ли на нее отрицательное влияние сопровождающие ее лица. Это устраняется в разьяснительной беседе.

Принимающий врач (акушерка) после акушерского осмотра напоминает, что при нормальных родах нет оснований для беспокойства роженицы. Тут же роженице задается вопрос о пройденной подготовке и подтверждается ее целесообразность и эффективность.

На основе объективных данных устанавливается диагноз и этап родового акта (начало периода раскрытия, кульминация раскрытия и т. д.).

В родильных домах желательно выделить отдельной предродовой палаты для беременных,готавливаемых или подготовленных

по психопрофилактическому методу. В родильных домах, где это невозможно, следует избегать помещения подготовленных рожениц в одной предродовой палате с очень беспокойно рожаящими женщинами, а тем более с роженицами, у которых роды протекают патологически, учитывая возможность отрицательной индукции со стороны последних.

Врач рекомендует применение приемов в соответствии с установленным этапом родового акта. В начальном периоде раскрытия роженице рекомендуется только использовать правильное дыхание.

В кульминационной фазе периода раскрытия, когда частота и продолжительность схваток нарастают и интервалы между схватками достигают 3—4 минут, рекомендуется применять поглаживания кожи нижней половины живота, сочетая их с вдохами и выдохами. В случае, когда раскрытие затягивается, необходимо усилить использование приемов: чередовать прием поглаживания с третьим приемом — прижатием точек обезболивания.

За правильным применением всех приемов наблюдает акушерка или врач, периодически подкрепляя их одобрением, усиливая их при необходимости и следя за точностью их выполнения. Врач указывает роженице на то, чтобы она выполняла все приемы без суетливости и напряжения, следит за тем, чтобы приемы не были преждевременно исчерпаны.

В случае затяжного течения родов, кроме приведенных выше психопрофилактических мероприятий, может быть использован психотерапевтический метод косвенного внушения, для чего применяемые обычно в этих случаях вливания глюкозы и ингаляции кислорода опосредствуются как обезболивающие средства.

Врач (или акушерка) записывает в историю родов характер схваток, высоту стояния головки, сердцебиение плода, поведение и жалобы роженицы.

Следя за течением родов, врач (или акушерка) своевременно дает разрешение вырабатывать потуги. Необходимо организовать поведение роженицы в соответствии с подготовкой.

В момент выведения головки снова ожигляются воспитанные при подготовке приемы для этого момента.

Влагалищное исследование, осмотр в зеркалах, все прочие манипуляции проводят после предварительного осведомления роженицы о том, что они принадлежат к обычным манипуляциям, к которым прибегают при ведении родов.

В случае появления беспокойства или жалоб на боли следует приступить к анализу причин этого беспокойства на основании подробного обследования роженицы. Часто причинами болей бывает задержка вскрытия плодного пузыря при полном раскрытии шейки, ригидность шейки матки, особенно наружного зева, ущемление губы шейки и некоторые другие отклонения от нормального течения родового акта. Своевременное устранение этих явлений, как правило, может снять болевые реакции. Пассивное ведение родов или неточность диагностики ведет к удлинению родов и истощению воспитанных приемов обезболивания.

По окончании родов врач или акушерка, проводившие роды, должны дать оценку применявшемуся методу обезболивания. Эта

оценка основывается на объективно наблюдаемых признаках поведения роженицы (двигательные реакции, мимика, крики) и на анализе субъективных ощущений в родах самой роженицей по ее личным заявлениям.

**РАЗРЫВ МАТКИ И ЦЕПКИ ПРОМЕЖНОСТИ.** Разрыв матки. Различают разрывы полные и неполные; самопроизвольные и насильственные; угрожающие и свершившиеся.

**Полный разрыв** — стенка матки и покрывающая ее брюшина (периметрий) разорваны. Через отверстие в матке в брюшную полость нередко проходят части плода, а при обширных разрывах выпадает весь плод целиком.

**Неполный разрыв.** Разрывается мышечный слой (целиком или частично) тела матки; брюшина остается целой. Обычно разрыв происходит в области нижнего маточного сегмента; при этом отверстие вскрывается между листками широкой связки.

**Самопроизвольные разрывы** являются следствием патологических изменений стенок матки.

**Насильственные разрывы** являются следствием вмешательства при родах (поворот на ножку, щипцы и т. д.), травмы.

**Причины.** Узкий таз, запущенное поперечное положение плода, неправильное вставление головки плода, ригидность шейки матки, патологические изменения стенок матки (дегенеративные, воспалительные), ненормально большая величина подлежащей части, аномалии родовой деятельности.

**Угрожающий разрыв матки. Симптомы.** Спазматические схватки; резко болезненные сокращения матки почти без пауз при отсутствии поступательного движения головки.

Стенки нижнего сегмента матки чрезмерно растягиваются. Контракционное кольцо стоит высоко, несколько ниже уровня пупка или на уровне пупка; матка принимает форму песочных часов; круглые связки значительно напряжены; роженица возбуждена; испытывает резкие боли; пульс частый, температура несколько повышена.

**Ведение родов.** Внутреннее исследование лучше не производить; к нему приходится прибегать только по строгим показаниям (производится врачом под глубоким наркозом!).

Исключить дальнейшие сокращения матки(!).

Дать глубокий наркоз.

При высоко стоящей головке и живом доношенном плоде, при наличии соответствующих условий и отсутствии противопоказаний (инфекция в родах, давно отошедшие воды) делают кесарево сечение.

При мертвом плоде или при наличии противопоказаний к кесареву сечению при живом плоде производят плодоразрушающую операцию. **Щипцы строго противопоказаны(!).**

Если акушерка работает самостоятельно (в колхозном родильном доме или на фельдшерско-акушерском пункте), то в случае наступления симптомов угрожающего разрыва матки она должна немедленно ввести роженице 1 мл 2% раствора морфина и срочно вызвать врача,

«

**Признаки свершившегося разрыва матки и.** Внезапное прекращение родовой деятельности, апатия, признаки венозного кровотечения (резкая бледность, частый нитевидный пульс), иногда полубморочное состояние.

**При-** пальпации живота отмечается отсутствие строго очерченных контуров матки; матка не напряжена; при полных разрывах матки, когда плод находится в брюшной полости, непосредственно под брюшной стенкой легко прощупываются мелкие части плода.

**Лечение.** При свершившемся разрыве матки показано немедленное кровоостановление, извлечение плода и последа; в зависимости от формы разрыва матки (полный или неполный), обширности разрыва и общего состояния больной в одних случаях показано удаление матки, а в других — тщательное зашивание разрыва.

После операции делают переливание крови в количестве 600—800 мл, под кожу вводят камфору, адонилен, назначают пенициллин по 50 000—100 000 единиц через 3 часа, сульфаниламидные препараты по 1 г 4—5 раз в день.

**Разрывы шейки матки.** Значительные кровотечения при разрывах шейки матки наступают после рождения плода. В этих случаях осмотр зеркалами совершенно обязателен.

При установлении разрыва шейки акушерка должна немедленно вызвать врача. До прибытия врача, в случае сильного кровотечения, акушерка туго тампонирует стерильным марлевым бинтом влагалище. Если тампонада не помогает, а врач лишен возможности срочно прибыть в стационар, акушерка самостоятельно зашивает разрыв.

**Разрывы промежности.** Различают три степени разрывов промежности: разрыв задней спайки входа во влагалище и кожи промежности (первая степень), разрыв промежности до заднего прохода (вторая степень) и разрыв промежности и сфинктера прямой кишки (третья степень).

**Лечение.** Послойное зашивание разрыва немедленно после родов. Ежедневная (два раза в день) обработка промежности спиртом и иодом или смазывание йодиноловой мазью.

**РВОТА БЕРЕМЕННЫХ.** Рвота появляется обычно в первой половине беременности. Легкие степени рвоты не представляют опасности и обычно к 3—4 месяцам беременности прекращаются. Однако можно наблюдать переход обычной рвоты в неукротимую, которая представляет значительную опасность для жизни беременной.

Неукротимая рвота сопровождается резкой интоксикацией всего организма; особенно поражаются при этом печень и почки.

**Симптомы и течение.** В начале заболевания отмечается тошнота и незначительная рвота 1—2 раза в день. В дальнейшем рвота учащается, развивается общая слабость, значительное падение в весе, пульс учащен, температура повышена. Диурез резко падает; в моче белок, цилиндры, кровь, ацетон; в крови — накопление оксималяной кислоты, ацидоз; отмечаются мозговые явления (галлюцинации). Тяжелые и запущенные случаи могут привести к смерти.

**Распознавание.** Необходимо исключить другие причины рвоты: заболевание желудочно-кишечного тракта, пищевые интоксикации и т. д.

**Лечение.** Беременная, у которой рвота возникает ежедневно 2—3 раза в день, должна направляться в стационар. В этих случаях необходимо постельное содержание, физический и душевный покой; растительно-молочная диета, прием пищи малыми порциями 6—8 раз в день, общее облучение кварцевой лампой (на расстоянии 1 м), малые дозы брома с кофеином по И. П. Павлову: 1% раствор бромистого натрия 3—4 раза в день по одной столовой ложке и подкожное введение 1 мл 10% раствора кофеина один раз в день в течение 8—10 дней. Внутривенно — хлористый кальций (10 мл 10% раствора), 50 мл 40% раствора глюкозы с аскорбиновой кислотой, под кожу — физиологический раствор или 5% раствор глюкозы по 1 л один-два раза в день.

При отсутствии эффекта от перечисленных мероприятий при наличии ацетона в моче, стойком повышении температуры выше 37,5°, стойком учащении пульса выше 100 ударов в минуту, похудании беременность необходимо прервать (по разрешению абортной комиссии).

**РОДЫ.** Роды представляют собой физиологический процесс, в результате которого происходит отделение от материнского организма всего плодного яйца, т. е. плода, плаценты и оболочек. Родовой акт делится на три периода: 1) период раскрытия, 2) период изгнания и 3) последовый период. Продолжительность родов в среднем у первородящих 20—24 часа, из которых 18—20 часов падают на период раскрытия, а 2—4 часа — на период изгнания; у повторнородящих роды в среднем длятся 10—12 часов, из которых  $\frac{1}{2}$ —1 час падает на период изгнания.

Раскрытие шейки матки осуществляется за счет ритмических сокращений матки (родовые схватки) и действия плодного пузыря, который постепенно и систематически внедряется в шейный канал и способствует, таким образом, раскрытию шейки. Раскрытие шейки у первородящих и повторнородящих происходит различно. У первородящих процесс раскрытия протекает следующим образом: вначале шейка истончается — происходит так называемое сглаживание шейки; когда шейка сглажена, начинается процесс раскрытия. У повторнородящих процессы сглаживания и раскрытия протекают одновременно. Степень раскрытия шейки определяется путем внутреннего исследования (опытная акушерка может определить степень раскрытия шейки и путем ректального исследования); если канал шейки пропускает один палец, говорят, что шейка раскрыта на один палец; если канал пропускает 2 пальца, говорят о раскрытии на 2 пальца; когда канал шейки пропускает 4 пальца, говорят о полном раскрытии шейки.

В норме, когда шейка полностью раскрыта, при наличии сильной схватки (сокращения матки) околоплодные воды с силой внедряются в ту часть плодного пузыря, которая находится в шейном канале, — происходит разрыв пузыря и отходят так называемые передние воды, т. е. те воды, которые скопятся между головкой плода и околоплодным пузырем. Задние воды отходят после рожде-

ния плода. Если плодный пузырь разорвался до полного открытия шейки, воды отходят ранее срока. Такое раннее отхождение вод является неблагоприятным симптомом, так как предстоит так называемые сухие роды, в связи с чем увеличивается опасность восхождения инфекции в полость матки.

Когда период раскрытия закончился, начинается период изгнания плода. Изгнание плода осуществляется за счет сокращения матки и работы брюшного пресса. Таким образом, получается комбинированное (в смысле изгоняющих сил) воздействие на плод, которое состоит за счет двух моментов: внутриматочного и внутри-брюшного давления. В период изгнания роженица начинает тужиться, инстинктивно упирается ногами в кровать, в спинку кровати, прижимает подбородок к груди, и таким путем увеличивается внутривнутрибрюшное давление. Головка постепенно подвигается книзу и впереди и начинает во время схваток показываться в половой щели. Вне схватки головка отходит несколько назад. При хорошей родовой деятельности головка постепенно начинает прорезываться через наружные половые органы. После рождения головки весьма быстро проходит и туловище плода, и второй период родов, т. е. период изгнания плода, заканчивается. Самым трудным и ответственным моментом в акте родов является рождение головки.

Для того чтобы правильно оценить ход родов и ориентироваться в динамике родового акта, необходимо знать биомеханизм прохождения головки через тазовое кольцо. Рассмотрим биомеханизм родов при наиболее часто встречающемся переднем виде затылочного предлежания. В начале периода изгнания стреловидный шов стоит поперечном размере входа в таз. Большой и малый роднички находятся на одном уровне. При первой позиции плода большой родничок находится справа, малый — слева.

В механизме родов мы различаем четыре момента: 1) сгибание, 2) внутренний поворот, 3) разгибание и 4) наружный поворот. При сгибании подбородок плода прижимается к груди, большой родничок поднимается вверх, малый родничок опускается книзу. Малый родничок будет являться проводной точкой, так как он все время проходит впереди по проводной оси таза. Затем головка производит внутренний поворот, который заключается в том, что стреловидный шов перемещается из поперечного размера при входе в таз сначала в косой (правый) полости таза и, наконец, в прямой размер выхода из таза. К этому времени большой родничок находится вверху у крестцовой впадины, а малый родничок — книзу у лонного сочленения. Так заканчивается внутренний поворот. Стреловидный шов находится в прямом размере выхода таза, продолжают дальнейшие поступательные движения головки. Впереди идет затылок и малый родничок (проводная точка). Эти поступательные движения продолжают до тех пор, пока под лонно не подойдет подзатылье. Подзатылье упирается в лонную дугу, и головка производит разгибательное движение. Таким образом, подзатылье является точкой фиксации (гипо-мохлином), вокруг которой происходит разгибание головки и фактическое ее рождение. Затем наступает четвертый момент, т. е. наружный поворот. Головка поворачивается затылком к бедру матери

одноименной позиции: в данном случае — затылком к левому бедру и лицом к правому бедру матери. Вслед за рождением головки довольно быстро происходит рождение плечиков и всего туловища плода. Как только родится плод, перевязывают пуповину, обрабатывают глаза новорожденного (вливать в оба глаза по 1—2 капли 2% раствора ляписа). Однако родовой акт еще не закончен. Предстоит провести так называемый последовый период, т. е. период от рождения ребенка до рождения плаценты. В последовом периоде, если нет сильного кровотечения, акушерка не должна вмешиваться, выжидая самостоятельного рождения плаценты. При этом необходимо наблюдать за пульсом роженицы и количеством теряемой ею крови. Если кровопотеря превышает 300—400 мл, необходимо ускорить отделение и выделение плаценты. Возможно, что плацента уже отделилась от стенки матки, но еще не выделилась из ее полости.

Какие же существуют признаки для суждения о том, отделилась ли плацента или нет? Когда плацента еще не отделилась, матка обычно имеет круглую форму. Если плацента отделилась и находится в нижней половине матки, тело матки начинает вытягиваться и приобретает форму песочных часов. Некоторые авторы предлагают наблюдать за тесьмой, которой перевязана пуповина. Если тесьма опускается, значит плацента отделилась, но еще не выделилась. Можно запомнить еще и следующий способ: ребром ладони надавливают на живот над лобком. Если при этом пуповина уходит внутрь, значит плацента еще не отделилась, в противном случае говорят об отделившейся уже плаценте. Если нет кровотечения, выжидают один час. Однако по прошествии часа для выделения плаценты можно прибегнуть к методу Абуладзе, который заключается в следующем: кожу и подкожную клетчатку брюшной стенки берут в складку и заставляют женщину потужиться. При этом приеме усиливается сила потуги, а вместе с тем и внутри-брюшное давление, в результате чего уже отделившаяся плацента легко выходит наружу.

Если же метод Абуладзе не дает положительного результата, необходимо применить метод Креде, который заключается в следующем: 1) опорожняют мочевой пузырь, 2) матку выводят на среднюю линию, 3) производят массаж матки до тех пор, пока она хорошо сократится. После этого приступают к выжиманию последа. Для этого акушерка становится с левой стороны роженицы, четырьмя пальцами заходит через брюшной покров за заднюю стенку матки, большой палец кладет на переднюю стенку матки и производит сжатие ее стенок; обычно этим путем удается выжать плаценту. Если брюшная стенка сильно напряжена и больная противодействует проведению метода Креде, можно применить метод Креде под наркозом. Если даже под наркозом выделить плаценту методом Креде не удастся, производят ручное отделение последа (см. *Задержка плаценты*).

После самостоятельного рождения, так же как и после выделения последа по Абуладзе, Креде или при помощи какого-либо другого метода, как правило, надо тщательно осмотреть послед для того, чтобы убедиться в его целостности. Если плацента вышла не вся, целиком, необходимо произвести ручное обследование полости

## р

матки и удалить из нее остатки плацентарной ткани. Задержавшиеся в матке кусочки оболочек удалению не подлежат, они сами выделяются с послеродовыми лохиями.

После рождения последа роженица остается 2—3 часа в родильной комнате (возможность кровотечения!), после чего переводится в отделение для родильниц.

**СЛАБОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.** Различают первичную и вторичную слабость родовой деятельности. Первичной родовой слабостью называется недостаточная родовая деятельность, проявляющаяся с самого начала родового акта, вторичной — ослабление родовой деятельности после некоторого времени значительно и хорошо выраженной родовой деятельности.

Причинами первичной слабости родовой деятельности является слабость маточной мускулатуры (инфантилизм), общая слабость всего организма роженицы, чрезмерное растяжение стенок матки (многоводие, многоплодие), наличие опухоли матки (фибромиома), уродства матки (двурогая матка), недостаточная или неправильная функция желез внутренней секреции, переполнение мочевого пузыря. Вторичная родовая слабость может зависеть от тех же причин, но к ним нужно присоединить еще общую слабость, усталость роженицы, наличие препятствий к продвижению предлежащей части плода (узкий таз, опухоли в области малого таза), для преодоления которых организм произвел вначале интенсивную работу в виде активных сокращений матки, что в последующем привело к усталости, истощению маточной мускулатуры.

**Осложнения.** Особенно после отхождения околоплодных вод (сухие затяжные роды): инфицирование родовых путей, некроз тканей матки матери в результате длительного прижатия их к костным стенкам таза, возможность асфиксии плода, недостаточная сократительная способность матки в последовом и послеродовом периоде и т. д.

**Лечение.** Роженицу заставляют часто опорожнять мочевой пузырь, а если это ей не удается, опорожняют его путем катетеризации.

При отсутствии полного раскрытия шейки назначают дробные дозы питуитрина по 0,2 через каждые 30 минут. Вместо питуитрина с хорошим эффектом применяют маммофизин (комбинация гормона задней доли гипофиза и грудной железы) в тех же дозах. Весьма часто инъекции питуитрина или маммофизина сочетают с приемом касторового масла. Вначале дают две столовые ложки касторового масла, а через 4 часа начинают вводить питуитрина или маммофизина, как было указано выше; внутривенно 50 мл 48% раствора глюкозы.

При первичной родовой слабости и целостности плодного пузыря рекомендуется впрыснуть внутримышечно 10 000 единиц фолликулина и 2 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты. Через час производят инъекцию питуитрина или маммофизина, как было указано выше. При полном раскрытии шейки можно сразу ввести 1 мл питуитрина или маммофизина, чего нельзя делать при отсутствии полного раскрытия шейки матки, так как после инъекции 1 мл питуитрина или маммофизина могут наступить бурные роды, а при недостаточном раскрытии шейки произойти ее разрыв:



Противопоказаниями к применению питуитрина и маммофизина являются: перерастяжение нижнего маточного сегмента (угроза разрыва матки), неправильное положение плода (поперечное, косое), неправильное вставление (лобное, лицевое, передне-теменное), эклампсия, преэклампсия, гипертония, наличие механических препятствий к продвижению подлежащей части плода.

В тех случаях, когда вторичная слабость наступает после длительной и безрезультатной сократительной деятельности матки, при наличии общей усталости роженицы и явлений переутомления мускулатуры матки необходимо дать роженице возможность отдохнуть. В таких случаях вводят 1 мл 1% пантопона: после некоторого отдыха может наступить весьма активная родовая деятельность.

**СХВАТКИ СУДОРОЖНЫЕ.** Продолжительные, почти без пауз, резко болезненные схватки наступают главным образом в результате растяжения нижнего маточного сегмента, при узком тазе, при запущенном поперечном положении плода, в результате грубого влагалищного исследования, назначения во время родов препаратов спорыньи (эрготина) и др.

**Течение.** Роженица беспокойна, схватки следуют одна за другой; в промежутках матка не расслабляется — остается в состоянии длительного судорожного сокращения. Роды не идут.

При сокращении матки нарушается плацентарное кровообращение и создается угроза асфиксии плода.

Судорожные сокращения матки в последовом периоде могут повести к ущемлению плаценты.

**Лечение.** Вначале применяют инъекции морфина 1 мл 1% раствора подкожно, а в случае отсутствия эффекта — эфирный наркоз.

При запущенном поперечном положении плода, узком тазе и явлениях угрожающего разрыва матки родоразрешение проводят под глубоким наркозом (см. *Положения плода поперечные. Разрыв матки*).

**ТРАВМАТИЗМ В РОДАХ. ПРОФИЛАКТИКА.** В целях организации успешной борьбы с осложнениями при родах и предупреждения тяжелого акушерского травматизма от руководителей органов и учреждений здравоохранения, а также от родовых работников учреждений родовспоможения и других медицинских учреждений требуется особо внимательное и квалифицированное обслуживание беременных, рожениц и новорожденных.

Для предотвращения тяжелых осложнений во время беременности и родов и в особенности для предупреждения образования свищей и разрывов матки необходимо руководствоваться следующими положениями.

Врачи акушеры-гинекологи как в городах, так и в сельских местностях, врачи сельских врачебных участков, акушерки колхозных родильных домов и фельдшерско-акушерских пунктов обязаны брать на учет всех беременных, проживающих в районе их деятельности, с первых месяцев беременности. С целью систематического наблюдения за беременными в первой половине беременности необходимо проводить ежемесячный осмотр женщин, а в последние два месяца беременности осматривают их через каждые две недели.

а)

При первом же посещении беременной должно быть уделено особое внимание данным анамнеза (рахит, костные заболевания и повреждения таза, течение и исходы предшествующих беременностей и родов, вес новорожденных, причина мертворождений, перенесенные воспалительные заболевания половых органов, аборт, особенно преступные).

Наряду с методами наружного акушерского обследования беременной (размеры таза, высота стояния дна матки, окружность живота и т. п.), необходимо применять и влагалищное исследование. Последнее производится при первом же посещении с целью измерения диагональной конъюгаты, выявления опухолей в малом тазу, экзостозов и других костных изменений таза, а также для выявления грубых рубцовых изменений мягких родовых путей, препятствующих естественному родоразрешению. В сомнительных случаях беременная должна быть направлена для более детального обследования в родильный дом (отделение).

Необходимо организовать особый учет (картотеку) и тщательное систематическое наблюдение за беременными с неправильным положением плода (поперечным, косым), с узким тазом, а также с неблагоприятным акушерским анамнезом (осложненные предшествующие роды). Таких беременных необходимо систематически патронировать, направлять в отделения (палаты) беременных но позже чем за 2 недели до родов и обязательно контролировать своевременность их поступления в родильный дом.

Акушерки колхозных родильных домов и фельдшерско-акушерских пунктов должны обязательно консультировать у врача участка или районного акушера-гинеколога всех беременных женщин, в течение беременности которых имеются какие-либо отклонения.

Если участковый врач затрудняется поставить диагноз и решить вопрос о прогнозе родов, то он должен направить беременную в отделение для обследования, а если нужно и для стационарного наблюдения в районный центр к врачу акушеру-гинекологу.

При направлении беременной в стационар необходимо выдать обменную карту, в которую заносятся все данные анамнеза, особенности течения беременности, размеры таза, данные анализов мочи, крови и т. п.

При поступлении в родильный дом (отделение) беременной с узким тазом, неправильным положением плода и другими отклонениями, грозящими патологическим течением родов, должно быть произведено очень тщательное обследование (подробный анамнез, наружное и внутреннее измерение таза, при возможности рентгенография таза и головки плода и пр.) и составлен план ведения родов, который заносится в историю родов.

При неблагоприятном анамнезе бывших ранее родов (мертворождение или плодоразрушающая операция), в случаях, где имеются сомнения в соответствии таза матери и головки плода, следует тщательно взвесить возможность самостоятельного родоразрешения. При значительном несоответствии таза и головки и настойчивом желании женщины иметь живого ребенка необходимо совместно с руководителем учреждения обсудить вопрос о возможности абдоминального родоразрешения (кесарево сечение).

В случаях, когда родовая деятельность достаточно энергична, период открытия закончился в обычный срок, воды отошли, а в периоде изгнания (полное открытие зева, головка прижата ко входу малого таза или находится в нем малым сегментом) обнаружено отсутствие поступательного движения предлежащей части в течение 4—5 часов, следует поставить вопрос об абдоминальном родо-разрешении. Наиболее совершенным методом абдоминального кесарева сечения во всех случаях и особенно при отошедших водах следует считать метод поперечного рассечения матки в нижнем сегменте по методу Русакова.

При поперечных положениях плода необходимо руководствоваться следующими указаниями:

А. При живом жизнеспособном плоде и нормальных размерах таза показано:

а) при малом открытии зева вместо опасного для матери и плода поворота на ножку по методу Бракстон-Гикса — введение кольпайринтера (при целом плодном пузыре) или метрейринтера (при отошедших околоплодных водах);

б) при целом плодном пузыре и полном открытии зева — вскрытие плодного пузыря с одновременным применением поворота плода на ножку и извлечением его;

в) при полном открытии зева с недавним отхождением околоплодных вод и при полном сохранении подвижности плода — внутренний поворот на ножку с извлечением;

г) при отсутствии подвижности плода и настойчивом желании матери сохранить его жизнь — абдоминальное родоразрешение при отсутствии противопоказаний (инфекции).

Б. При сужениях таза, препятствующих прохождению головки через костное кольцо, жизнь плода может быть сохранена путем применения при надлежащих условиях абдоминального родоразрешения.

В. При запущенном поперечном положении плода, сочетающемся с внутриутробной смертью его, показана только эмбриотомия. В случаях, когда головка прижата ко входу малого таза или стоит малым сегментом во входе его, наложение \*щипцов (высоких) запрещается. При безусловных показаниях к родоразрешению в таких случаях следует применить или абдоминальное кесарево сечение, или краниотомию.

Операция абдоминального кесарева сечения в каждом случае применения требует тщательной оценки показаний и противопоказаний и должна выполняться в надлежащих условиях при наличии достаточного опыта у врача. Необходимо помнить, что эта операция в ряде случаев может дать серьезные осложнения, даже смертельный исход, поэтому необоснованное расширение показаний к ней недопустимо. Показания к абдоминальному родоразрешению надо особенно осторожно ставить у молодых первородящих.

Врачи и акушеры должны своевременно и подробно отражать в истории родов все особенности течения родов, общее состояние роженицы, характер родовой деятельности, поступательные движения и сердцебиение плода, целостность плодного пузыря, характер выделе-

ний из влагалища (воды, кровь, меконий), степень наполнения мочевого пузыря и возможность самостоятельного его опорожнения. Время каждого осмотра должно быть указано в часах и минутах.

**ТРЕЩИНЫ СОСКОВ.** Могут наступить как во время беременности, так и вне ее, но чаще они возникают в период кормления (при недостаточном уходе за грудными железами). При сосании происходит смачивание кожи сосков и мацерация их покровов. Рациональная профилактика и лечение трещин сосков являются актуальной задачей медицинского персонала, так как правильные мероприятия в этом отношении являются профилактикой мастита.

**Профилактика.** Строго следить во время беременности за чистотой грудных желез, особенно сосков; два раза в день обливать соски кипяченой водой и смазывать стерильным вазелиновым маслом, соблюдая при этом все правила асептики. Плоские соски два раза в день вытягивать; бюстгальтер должен точно соответствовать размеру грудных желез. После каждого кормления тщательно оомиывать соски слабым раствором борной кислоты, вытирать насухо и прикладывать стерильную марлю, смоченную в стерильном вазелиновом масле.

**Лечение.** При трещинах сосков кормление следует производить через накладку. После каждого кормления обмывать и высушивать соски и прикладывать мазь следующего состава;

Rp. Anaesthesini 3,0  
Bismuti subnitrici 2,0  
Streptocidi albi 5,0 01. Jecoris  
Aselli 50,0 MDS. Наружное

Rp. Penicillin"! 25 000 единиц Aq.  
destill. 1,0 01. Vaselini 50,0  
MDS. Наружное

Хороший эффект дает облучение кварцевой лампой.

**ЭКЛАМПСИЯ, ПРЕЭКЛАМПСИЯ (ECLAMPSIA, PRAEECLAMPSIA).** Тяжелый токсикоз беременности, характеризующийся наступлением судорог, отеков, наличием белка в моче и" повышением кровяного давления. Наиболее типичным признаком эклампсии являются клонические судороги мышц лица, а затем и всего тела.

Различают эклампсию во время беременности, во время родов и после родов.

**Течение.** Наступлению эклампсии предшествует ряд нерезко выраженных явлений, которые представляют как бы продромальную стадию возможного экламптического припадка. Это состояние называется эклампсизмом, или преэклампсией.

Нередко эклампсии предшествует нефропатия беременных {см.) — заболевание, связанное с изменением в эпителии почечных канальцев характера перерождения, но не воспаления.

При эклампсизме наблюдается наличие белка в моче, отеки. Быстро нарастающий отек (нарастание в весе свыше 300 г в неделю),

наличие высокого артериального давления (140—150 мм и выше) являются тяжелой формой токсикоза беременности; создается возможность перехода таких форм токсикоза, как нефропатия беременных или водянка беременных, в эклампсию.

При описанных симптомах женщина должна быть немедленно госпитализирована и проведено энергичное лечение (диететический режим, покой, инъекции 25% раствора сернокислой магнезии по 2Q мл 3 раза в день, кровопускание по показаниям и др.).

Если явления эклампсии нарастают (повышается кровяное давление, нарастают отеки, увеличивается количество белка в моче, наступает головная боль, падает зрение вследствие спазма сосудов и изменений со стороны глазного дна, появляется рвота), внезапно наступает экламптический припадок. Беременная падает; появляются судороги мышц лица, фибриллярные подергивания лицевых мышц, постепенно распространяющиеся на мышцы конечностей и туловища. Фибриллярные подергивания переходят в значительно выраженные тонические судороги, появляется резкая синюшность лица вследствие затруднения или даже прекращения дыхания; зрачки расширяются; больная находится в бессознательном состоянии.

Кульминационный пункт припадка и остановка дыхания продолжаются от 30 секунд до 1 минуты. Весь припадок в целом может продолжаться 2—3 минуты.

Затем судороги постепенно уменьшаются в своей интенсивности, больная производит глубокий вдох, изо рта выделяется белая пена, иногда окрашенная кровью (вследствие прикуса языка). Постепенно дыхание восстанавливается и синюшность исчезает. Через некоторое время больная приходит в сознание. Впрочем, в тяжелых случаях даже в промежутках между припадками больная остается в бессознательном состоянии.

Чем меньше количество припадков, тем лучше прогноз.

Уменьшение количества белка, снижение кровяного давления, увеличение количества мочи (повышение диуреза) являются благоприятными прогностическими признаками. \*

В тех случаях, когда больная не приходит в сознание, припадки часто повторяются, количество белка в моче увеличивается, кровяное давление не падает, больная может погибнуть от отека легких, асфиксии, кровоизлияния в мозг, а также вследствие перерождения жизненно важных паренхиматозных органов (печень, почки), а нередко и от присоединяющейся инфекции (сепсис, пневмония).

**Лечение.** Ввиду того что малейшее раздражение, как внутреннее исследование, всевозможные манипуляции (клизмы, инъекции) и даже незначительный шум и свет, вызывают повторение и учащение экламптических припадков, больную необходимо немедленно изолировать в отдельную комнату с глухо закрывающейся дверью, а еще лучше с тамбуром; окна завешивают специальными шторами или, если таковых нет, одеялами, не пропускающими света; свет от лампы должен быть неярким, а настольная лампа прикрыта колпаком.

Больную укладывают в теплую кровать и все ее тело, в особенности область почек, обкладывают грелками.

В комнате должно быть все приспособлено для подкожных впрыскиваний, кроме того, здесь должна иметься подушка с кислородом, а также резиновый брусок или ложка с ручкой, несколько раз обернутой марлей (для профилактики прикусывания языка).

Необходимо обеспечить неотлучное наблюдение акушерки.

Если больная поступила в стадии преэклампсии, ей назначают ограниченный прием жидкости (100—120 мл в сутки), полностью исключают из рациона поваренную соль, предписывают голодание, внутрь дают 25 г сернокислой магнезии (для выподепия жидкости через кишечник) и люминал 0,1 два-три раза в день, внутримышечно 3 раза в день вводят по 20 мл 25% раствора сернокислой магнезии.

Если больная поступила в стационар при наличии у нее припадков, к лечению эклампсии приступают не дожидаясь наступления следующего припадка, так как лечение эклампсии является профилактикой возможных следующих припадков.

Все манипуляции (инъекции, клизмы и т. п.) производятся под легким эфирным наркозом.

При первых же признаках наступающего припадка между челюстями должен быть вставлен резиновый брусок или же ручка ложки, несколько раз обернутая марлей, во избежание прикуса и даже омертвления языка.

Общепризнан консервативный метод лечения эклампсии, но если имеются условия для бережного родоразрешения, желательно закончить роды.

Условия эти: предлежащая часть находится низко в полости или в выходе таза, полное открытие — наложение выходных щипцов, перинеотомия; при ягодичном предлежании — извлечение плода за тазовый конец.

**Схема лечения эклампсии по Строганову.** После первого припадка — 1 мл 1% раствора морфина.

Через час после первой инъекции — внутримышечно 30 мл 20% раствора сернокислой магнезии. - -

Через 3 часа после первой инъекции — 1 мл 1% раствора морфина под кожу.

В дальнейшем через каждые 4 часа, но не более четырех раз в течение суток, — по 30 мл 20% раствора сернокислой магнезии внутримышечно.

**Схема лечения эклампсии по Бровкину.** Каждые четыре часа (не более 4 раз в сутки) — внутримышечное введение по 30 мл 20% раствора сернокислой магнезии. Морфин не применяется (как антидиуретическое средство).

В случае отсутствия эффекта рекомендуется кровопускание из локтевой вены 400—500 мл после предварительного определения процента гемоглобина.

При низком проценте гемоглобина (ниже 50), особенно перед предстоящими родами, не следует делать массивных кровопусканий, так как во время родов может наступить значительное кровотечение, которое может оказаться весьма тяжелым для больной.

В тех случаях, когда консервативные методы лечения не дают эффекта, при ухудшении общего состояния больной и при отсутствии

условий для родоразрешения вагинальным путем, т. е. в и с к л ю ч и т е л ь н ы х с л у ч а я х , производится кесарево сечение.

Все беременные с явлениями эклампсии должны быть немедленно госпитализированы, так как лечение эклампсии может проводить только врач.

Если припадок начался на дому или на фельдшерско-акушерском пункте, больную необходимо срочно транспортировать в ближайшую больницу или родильный дом, а в тяжелых случаях — срочно вызвать к ней врача. До прибытия врача или до транспортировки больной акушерка обязана начать лечение по схеме Строганова или Бровкина .

Врача необходимо предупредить о причине вызова.

**ЯЗВЫ ПОСЛЕРОДОВЫЕ (ULCERA PUERPERALIA).** Этиология . Внедрение бактерий в места разрывов, надрывов и ссадин в области промежности и влагалища; воспалительные процессы.

**С и м п т о м ы .** Образование язв, покрытых сероватым гнойным налетом, в области промежности и влагалища; отек вульвы, гнойные выделения; чувство жжения во влагалище; субфебрильная температура.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Нетрудно на основании приведенных данных. Исключить сифилитические и дифтеритические язвы (бактериоскопическое и бактериологическое исследование налета).

**Л е ч е н и е .** Лед на промежность; тщательная и сухая уборка; присыпка порошкообразного белого стрептоцида; освещение промежности кварцевой лампой.

**П р о ф и л а к т и к а** Тщательное зашивание разрывов промежности и шейки немедленно после родов; смазывание мест разрывов и трещин стрептоцидовой или пенициллиновой мазью.

Rp. Streptocidi albi 10,0 01.  
Vasellini 30,0 MDS. Мазь

Rp. Penicillini 50 000 единиц  
Aq. destill. 1,0 01.  
Vasellini 30,0 MDS. Мазь

»

Добавление

### КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ ДОРОДОВОГО И ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА (по В. А. Петрову)

| Первый день последней менструации | Отпуск до родов (35 дней) с | Роды   | Сроки нвки на работу с длительностью отпуска после родов |         |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|
|                                   |                             |        | 42 дтп                                                   | 56 дней |
| 5/I                               | 7>IX                        | 12/X   | 23/XI                                                    | 7/XII   |
| 10/I                              | 12 IX                       | 17:X   | 28/XI                                                    | 12 XII  |
| 15/I                              | 17/IX                       | 22/X   | 3/XII                                                    | 17/XII  |
| 20/I                              | 22/IX                       | 27/X   | 8/XII                                                    | 22 XII  |
| 25/I                              | 27/IX                       | 1/XI   | 13/XII                                                   | 27/XII  |
| 30/I                              | 2/X                         | 6.XI   | 18/XII                                                   | 1/I     |
| 5.II                              | 8/X                         | 12/XI  | 24/XII                                                   | 7/I     |
| 10/II                             | 13 X                        | 17/XI  | 29/XII                                                   | 12/I    |
| 15/II                             | 18/X                        | 22/XI  | 3.I                                                      | 17/I    |
| 20/II                             | 23/X                        | 27/XI  | 8/I                                                      | 22/I    |
| 25/II                             | 28/X                        | 2/XII  | 13/I                                                     | 27/I    |
| 5/III                             | 5/XI                        | 10/XII | 21/I                                                     | 4/II    |
| 10/III                            | 10/XI                       | 15/XII | 26/I                                                     | 9/II    |
| 15/III                            | 15/XI                       | 20/XII | 31/I                                                     | 14/II   |
| 20/III                            | 20 XI                       | 25/XII | 5/II                                                     | 19/II   |
| 25/III                            | 25/XI                       | 30/XII | 10/II                                                    | 24/II   |
| 30/III                            | 30/XI                       | 4/I    | 15/II                                                    | 1/III   |
| 5/IV                              | 6/XII                       | 10/I   | 21.II                                                    | 7/III   |
| 10/IV                             | II/XII                      | 15/I   | 26/II                                                    | 12/III  |
| 15 IV                             | 16/XII                      | 20/I   | 3/III                                                    | 17/III  |
| 20/IV                             | 21/XII                      | 25/I   | 8/III                                                    | 22/III  |
| 25/IV                             | 26/XII                      | 30.I   | 13.III                                                   | 27/III  |
| 30/IV                             | 31/XII                      | ■ 4/II | 18/III                                                   | 1/IV    |
| 5/V                               | 5/I                         | 9 II   | 23/III                                                   | 6/IV    |
| 10/V                              | 10/I                        | 14/II  | 28/III                                                   | 11/IV   |
| 15/V                              | 15 I                        | 19/II  | 2/IV                                                     | 16/IV   |
| 20/V                              | 20/I                        | 24/II  | 7/IV                                                     | 21/IV   |
| 25/V                              | 25/I                        | 1/III  | 17 IV                                                    | 26/IV   |
| 30/V                              | 30I                         | 6/III  | 22/IV                                                    | 1/V     |
| 5/VI                              | 5/II                        | 12/III | 23.IV                                                    | 7.V     |
| 10/VI                             | 10/II                       | 17/III | 28/IV                                                    | 12/V    |
| 15/VI                             | 15/II                       | 22/III | 3/V                                                      | 17/V    |
| 20/VI                             | 20/II                       | 27.III | 8/V                                                      | 22/V    |
| 25/VI                             | 25/II                       | 1/IV   | 13/V                                                     | 27/V    |
| 30/VI                             | 2/III                       | 6/IV   | 18/V                                                     | 1/VI    |
| 5/VII                             | 7/III                       | 11/IV  | 23.V                                                     | 6/VI    |
| 10/VII                            | 12/III                      | 16/IV  | 28/V                                                     | 11/VI   |
| 15/VII                            | 17/III                      | 21/IV  | 2/VI                                                     | 16/VI   |
| 20/VII                            | 4 22 III                    | 26/IV  | 7 VI                                                     | «/VI    |
| 25/VII                            | 27/III                      | 1/V    | 12/VI                                                    | 26/VI   |
| 30/VII                            | 1/IV                        | 6/V    | 17/VI                                                    | 1/VII   |
| 5/VIII                            | 7/IV                        | 12/V   | 23/VI                                                    | 7/VII   |
| 10/VIII                           | 12/IV                       | 17/V   | 28/VI                                                    | 12/VII  |
| 15/VIII                           | 17/IV                       | 22/V   | 3/VII                                                    | 17/VII  |
| 20/VIII                           | 22/IV                       | 27/V   | 8. VII                                                   | 22/VII  |
| 25/VIII                           | 27/IV                       | 1/VI   | 13/VII                                                   | 27/VII  |
| 30/VIII                           | 2 V                         | 6/VI   | 18 VII                                                   | 1/VIII  |
| 5 IX                              | 8/V                         | 12/VI  | 24/VII                                                   | 7/VIII  |
| 10/IX                             | 13 V                        | 17/VI  | 29 VII                                                   | 12/VIII |
| 15/IX                             | 18/V                        | 22/VI  | 3/VIII                                                   | 17/VIII |
| 30/IX                             | 23/V                        | 27/VI  | 8/VIII                                                   | 22/VIII |
| 25/IX                             | 28/V                        | 2/VII  | 13/VIII                                                  | 27.VIII |

## Продолжение

| П^ррт гї день<br>последнее<br>менструации | Отпуск<br>до родов<br>(35 дней)<br>с | Роды    | Сгони яйки на работу с дли-<br>тельностью отпуска после родов |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                                           |                                      |         | 42 дня                                                        | 56 дней |
| 30/IX                                     | 2/VI                                 | 7/VI    | 18/VIII                                                       | 1/IX    |
| 5/X                                       | 7/VI                                 | 12/VI   | 23/VIII                                                       | 6/IX    |
| 10/X                                      | 12/VI                                | 17/VI   | 28/VIII                                                       | 11/IX   |
| 15/X                                      | 17/VI                                | 22/VI   | 2/IX                                                          | 16/IX   |
| 20/X                                      | 22/VI                                | 27/VI   | 7/IX                                                          | 21/IX   |
| 25/X                                      | 27/VI                                | 1/VIII  | 12/IX                                                         | 26/IX   |
| 30/X                                      | 2/VII                                | 6/VIII  | 17/IX                                                         | 1/X     |
| 5/XI                                      | 8/VII                                | 12/VIII | 23/IX                                                         | 7/X     |
| 10/XI                                     | 13/VII                               | 17/VIII | 28/IX                                                         | 12/X    |
| 15/XI                                     | 18/VII                               | 22/VIII | 3/X                                                           | 17/X    |
| 20/XI                                     | 23/VII                               | 27/VIII | 8/X                                                           | 22/X    |
| 25/XI                                     | 28/VII                               | 1/IX    | 13/X                                                          | 27/X    |
| 30/XI                                     | 2/VIII                               | 6/IX    | 18/X                                                          | 1/XI    |
| 5/XII                                     | 7/VIII                               | 11/IX   | 23/X                                                          | 6/XI    |
| 10/XII                                    | 12/VIII                              | 16/IX   | 28/X                                                          | 11/XI   |
| 15/XII                                    | 17/VIII                              | 21/IX   | 2/XI                                                          | 16/XI   |
| 20/XII                                    | 22/VIII                              | 26/IX   | 7/XI                                                          | 21/XI   |
| 25/XII                                    | 27/VIII                              | 1/X     | 12/XI                                                         | 26/XI   |
| 30/XII                                    | 1/X                                  | 6/X     | 17/XI                                                         | 1/XII   |

## Правила пользования календарем

1. Установив опросом у беременной дату первого дня последней менструации, на той же линии в календаре можно найти даты: например, начало последней менструации 20/VII—дородовой отпуск на 35 дней надо предоставить с 22/III, роды ожидаются 26/IV; если роды нормальные, женщина должна явиться на работу после 42-дневного отпуска, т. е. 7/VI; если же роды патологические, то 21/VI (отпуск 56 дней).

2. При пользовании календарем следует также учитывать объективные данные акушерского исследования (высота стояния дна матки над симфизом, величина головки плода и пр.).

3. В високосном году в январе и феврале сроки отпусков и родов следует уменьшать на один день.

4. Если последующий год високосный, то, начиная с 1 /III, срок родов и явка на работу после родов уменьшаются на один день.

## ГЛАВА VIII

## ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ (ГИНЕКОЛОГИЯ)

**АДНЕКСИТ (ADNEXITIS). ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ (ТРУБ И ЯПЧНИКОВ).**

Заболевание только труб или только яичников наблюдается крайне редко. Обычно отмечается комбинированное поражение придатков, т. е. труб и яичников, причем оно бывает односторонним (ооспа-ление правых или левых придатков) или двусторонним.

Воспалительный процесс вызывается в большинстве случаев стрептококком, стафилококком, гонококком, реже кишечной, туберкулезной палочкой. Нередко наблюдается комбинированное заболевание, т. е. воспаление матки и придатков.

При гонорройной инфекции в большинстве случаев имеет место двустороннее воспаление придатков матки.

**Симптомы и течение.** В острой стадии температура поднимается до 38—39° и даже 40°. Отмечаются резкие боли внизу живота, симптомы местного раздражения брюшины. Реакция осе-<дания эритроцитов (РОЭ) резко ускорена; лейкоцитоз, сдвиг фор-мулы белой крови влево. В хронической стадии температура суб-фебрильная или нормальная; частые обострения болей внизу {ки-> вота, особенно во время и после менструаций; обильные кровянистые выделения во время менструаций, удлинение менструального периода, укорочение межменструального промежутка; реже — атипические кровотечения, не связанные с менструацией.

**Р а с п о з н а в а н и е.** Тщательный анамнез. При внутр-с-\* нем исследовании матка несколько увеличена. Увеличенные с одной или с обеих сторон, отечные и болезненные придатки нередко образуют большие воспалительные опухоли, спаянные с кишечником, сальником и маткой, достигающие размеров кулака мужчины и даже больше.

**Л е ч е н и е** В о с т р о й с т а д и и покой, холод на низ живота, ректальные свечи с антипирином, аспирином, белладонной, при сильных болях — пантопон, морфин под кожу; внутрь — сульфаниламидные препараты (2 дня — 5 раз в день по 1,0; 2 дня — 4 раза в день по 1,0; 3 дня — 6 раз в день по 0,5). При наличии высокой температуры и резких болей — пенициллин 8 раз в сутки (через каждые 3 часа) по 30 000—50 000 единиц. Хорошие результаты дает аутогемотерапия; желательно сочетать аутогемо-терапию с внутривенным введением хлористого кальция.

**П р и х р о н и ч е с к о й ф о р м е** — тепловая и рассасывающая терапия (кварц, соллюкс на низ живота, абдоминально-сакральная или вагинально-сакральная диатермия, микроклизмы из ромашки).

В случаях, не поддающихся обычным методам лечения, рекомендуется лечение на курорте, грязевые аппликации, вагинальные грязевые тампоны.

В исключительных случаях, когда средства консервативной терапии не дают эффекта, прибегают к оперативному вмешательству.

- Rp. Ammonii sulfo-ichthyolici 10,0  
Glycerin i 90,0  
MDS. Для тампонов Rp. Ашшоии  
sulfo-ichthyolici 0,3  
But. Cacao 1,0  
M. f. glob. D. t. d. N. 12  
DS. По I шару в день Rp.  
Sol. Calcii chlorati 10% 10,0  
fa amp. D. t. d. N. 6  
Sterilisetur!  
DS. Для внутривенных вливаний Rp.  
Extr. Belladonnae  
Papaverini aa 0,02  
Antipyrini 0,5  
But. Cacao 1,0  
M. f. supp. D. t. d. N. 12  
DS. По I свече 1—2 раза в день  
Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 200,0  
DS. 3—4 раза в день по 1 столовой ложке  
Rp. Mammophysini  
in amp. a 1,0 D.  
t. d. N. 10  
DS. Внутримышечные инъекции по 1 ампуле в день  
Rp. Pituicrini «P» in amp. a 1,0 D. t.  
d. N. 10  
DS. Внутримышечные инъекции по 1 ампуле в день

**АМЕНОРРЕЯ (AMENORRHOEA). ОТСУТСТВИЕ МЕНСТРУАЦИИ.** Как физиологическое состояние наблюдается до наступления половой зрелости, в климактерическом возрасте, во время беременности и более или менее продолжительное время в период грудного кормления, как патологическое состояние — в результате заболеваний полового аппарата, при пороках развития полового аппарата (отсутствие матки, заращение шейки матки, влагалища), после экстирпации яичников или кастрации рентгеновыми лучами, при различных повреждениях слизистой оболочки матки, влекущих за собой нарушение ее функции (вливания в полость матки крепких растворов прижигающих веществ, механические разрушения слизистой, глубокие воспалительные процессы и пр.). Нередко аменоррея развивается на почве общих заболеваний (туберкулез легких, воспаление почек, болезни желез внутренней секреции, тяжелые анемии, психозы, язва желудка и др.), а также во время

и после острых заболеваний (тиф, скарлатина, холера, сепсис, малярия), в результате нервно-психических потрясений, при сильном переутомлении и на почве гипо- и авитаминоза.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Надо исключить все причины, ведущие к физиологической аменоррее.

**Л е ч е н и е .** Общеукрепляющее: усиленное питание, чистый воздух, умеренный спорт, подкожное введение мышьяка (30—40 инъекций), препараты железа, гематоген по 3 столовых ложки в день. Местное лечение, направленное на улучшение кровообращения в малом тазу: горячие спринцевания 40° кипяченой водой, горячие ножные или сидячие ванны, грязевые ванны или тампоны, влажалищная диатермия (20—30 сеансов).

При аменоррее на аочве гипо- и.ти авитаминоза — сырые овощи, фрукты, аскорбиновая кислота. При аменоррее на почве переутомления — покой, усиленное питание, гальванический воротник по Щербаку с хлористым кальцием (курс 15—20 процедур). При аменоррее на почве недостаточной функции яичников — подкожное или внутримышечное введение фолликулина или синэстрола, стильб-эстрола (по 5 000—10 000 единиц ежедневно в течение 10—15 дней). Избегать иода и его препаратов, так как они действуют па яичники угнетающим образом.

- Rp. Sol. Natrii kaltodvlici 5% 1,0  
D. t. d. N. 30 in amp.  
DS. По 1 мл под кожу 1 раз в день Rp.  
Ferri reducti 1,0  
D. t. d. N. 30 in obi.  
DS. По 1 облатке 3 раза в день  
Rp. Ac. ascorbinici 0,1  
Glucosae 3,0  
M. f. pulv. D. b. d. N. 30  
DS. 3 раза в день по 1 порошку  
Rp. Thiamini hydrochlorici 0,005  
Ac. nicotinici 0,02  
Ac. ascorbinici 0,06  
Sacchari 0,3  
M. f. pulv. D. t. d. N. 30  
DS. 3 раза в день по 1 порошку Rp.  
Folliculini  
fa amp. a 5 000 E  
B. t. d. N. 12  
DS. По.1 ампуле внутримышечно Rp.  
Sfaestrolu 0,001  
Sacchari 0,3  
M. i. pulv. D. t. d. N. 10  
DS. По I порошку в день Rp.  
Sol. Sinestrolu  
1% fa amp. a 1,0  
D. t. d. N. 6  
DS. Через день по 1 ампуле внутримышечно

Rp. Diaethylstilboestrol 0,001  
Sacchari albi 0,3 M. f. pulv. D.  
t. d. N. 10 DS. По 1 порошку в  
день

Rp. Sol. Glucosae 40% m amp. a 20,0 DS. Для  
внутривенных вливаний

**АТРЕЗИЯ (ATRESIA). ЗАРАЩЕНИЕ ВЛАГАЛИЩА, ШЕЙКИ МАТКИ.** Врожденная атрезия—следствие неправильного внутриутробного развития; приобретенная атрезия — следствие перенесенных детских инфекций (главным образом дифтерии, скарлатины, свинки), воспалительных заболеваний половой сферы в детском возрасте и во взрослом состоянии; неправильных медицинских манипуляций, спринцеваний крепкими растворами дезинфицирующих средств, родовой травмы и пр.

**Симптомы и течение.** В детстве симптомы отсутствуют. Они наступают только после появления менструаций, причем наружных кровотечений не бывает. Менструальная кровь, скапливаясь в закрытом половом канале, вызывает его перерастяжение, сопровождающееся резкими болями; периодически наступают вторичные явления, сопровождающие обычную менструацию.

В зависимости от места атрезии и давности ее существования кровь скапливается и растягивает влагалище (haematocolpos), матку (haematometra) и трубы (haematosalpinx); при нагноении кровяной опухоли отмечается высокая температура; иногда развивается сепсис.

**Лечение** оперативное.

**БЕЛИ (FLUOR).** При нормальной функции женских половых органов—незначительные выделения (0,5—2 мл в сутки), прозрачные или молочно-белые, жидкие, а иногда крошкообразные, без примеси крови, гноя, слизи. Отделяемое влагалища здоровой женщины содержит клетки плоского эпителия, единичные лейкоциты и незначительное количество микроорганизмов; реакция выделения большей частью кислая или слабокислая.

Кислотность влагалищного секрета зависит главным образом от наличия в нем молочной кислоты, образующейся из гликогена влагалища благодаря присутствию влагалищной палочки. Помимо влагалищной палочки, в патологических случаях (при заболеваниях половой сферы) в выделениях встречаются стрептококки, стафилококки, гонококки, туберкулезная палочка и др.

Различают три степени чистоты влагалищного секрета. При первой степени чистоты в мазке из влагалищного секрета, окрашенного по Граму, находят исключительно влагалищные палочки и незначительное количество клеток плоского эпителия. Реакция кислая. Первая степень чистоты наблюдается у женщин, не живших половой жизнью, не бывших и не болеющих гинекологическими заболеваниями. При второй степени чистоты в мазке находят меньшее количество влагалищных

палочек и, наряду с ними, коккобациллы, отдельные грамположительные диплококки и пр. Преобладают клетки плоского эпителия и часто наблюдаются отдельные лейкоциты. Вторая степень чистоты влагалищного секрета встречается у женщин, живших (и живущих) половой жизнью, но не болеющих гинекологическими заболеваниями. Реакция слабокислая. При третьей степени чистоты в мазке из влагалищного секрета влагалищная палочка обычно отсутствует, но находят много грамположительных и грамотрицательных бактерий, кокков, сарцин и др.; реакция щелочная. Третья степень чистоты встречается большей частью у женщин, больных гинекологическими заболеваниями.

Бели, содержащие гной, кровь, патогенные микробы, или очень обильные (даже без наличия патогенных микробов) «бели» требуют соответствующего лечения. Выделения могут быть белого (отсюда название «бели»), желтого и зеленого цвета; в результате примеси крови или некротизированной ткани цвет их может быть коричневым, буроватым.

Бели бывают без запаха или с запахом, иногда зловонным, они бывают не разъедающими или сильно разъедающими область наружных половых органов и бедер. В большинстве случаев бели являются признаком какого-либо заболевания женской половой сферы или общего заболевания организма (не полового аппарата).

Различают бели трубные, маточные, шеечные, влагалищные. Трубные бели встречаются крайне редко. Маточные бели наблюдаются при гонорройной или септическом поражении слизистой оболочки матки, реже на почве туберкулезного эндометрита; при аномалиях положения матки (при резком загибе), при доброкачественных новообразованиях (подслизистая миома) и злокачественных новообразованиях (рак). При раке матки бели имеют вид «мясных помоев», так как к отделяемому присоединяются продукты распада опухоли и кровь. Шеечные бели — симптом острого воспалительного заболевания, главным образом гонорреи. Они возникают также при полипе, раке шейки матки, иногда в результате длительного неправильного применения механических противозачаточных средств (колпачки). Влагалищные бели возникают при инфекционном процессе (например, гоноррея влагалища у девочек, дифтерия), при злокачественных новообразованиях (рак влагалища), при длительном ношении колец (в случае выпадения влагалища и матки), при мастурбации, наличии глистов, особенно острип; частой причиной влагалищных белей является трихомонада (см. *Вагинит трихомонадный*).

Диагностика белей должна быть направлена в сторону установления их этиологии и определения пораженного участка полового тракта. Для этого необходимо собрать самый тщательный анамнез, произвести микроскопический анализ выделений, осмотреть наружные половые органы, обследовать зеркалами влагалище и шейку матки (эрозия, полип, рак шейки матки). При внутреннем гинекологическом исследовании надо обратить внимание на наличие воспалительного процесса и новообразований (рак). При отсутствии изменений в половом аппарате надо тщательно несло-

довать весь организм (туберкулез, малокровие, хронический колит и т. п.).

Лечение должно быть направлено на основное заболевание. При любой этиологии белей рекомендуется провести общеукрепляющее лечение (введение мышьяка под кожу, назначение витаминов, умеренной физкультуры). Рекомендуется спринцевание 50% раствором сернокислого цинка — одна столовая ложка на кружку воды (вяжущее), раствором сухимы 1:2 000 (дезинфицирующее), 2% раствором марганцовокислого калия — одна столовая ложка на кружку воды (дезодорирующее), двууглекислой содой — 2 чайных ложки на кружку воды (для растворения слизи), борной кислотой — 2 чайных ложки на кружку воды (при трихомонадном кольпите).

Rp. Sol. Zinci sulfurici 50% 200,0

DS. 1 столовая ложка на 1 л воды для спринцеваний

ff

Rp. Sol. Kalii hypermanganici 2% 200,0

DS. 1 столовая ложка на 1 л воды для, спринцеваний

**БЕСПЛОДИЕ (STERILITAS).** Неспособность женщины в детородном возрасте воспроизводить потомство.

Виновником бесплодия может быть как женщина ( $\frac{2}{3}$  случаев), так и мужчина (^ случаев). Различают первичное бесплодие, когда беременность никогда не наступала, и вторичное, когда женщина становится бесплодной после одной или нескольких беременностей.

Причиной женского бесплодия является наличие различных нарушений в развитии женского полового аппарата (заращение влагалища, матки и труб, отсутствие матки, яичников), недоразвитие женских половых органов (коническая длинная шейка, очень маленькая матка, нередко с резким перегибом кпереди) и, наряду с недоразвитием, нарушение функции эндокринной системы (пониженная функция яичников). Большое значение в развитии бесплодия имеют опухоли женской половой сферы (фибромы, миомы, кисты, в особенности злокачественные новообразования).

Наиболее частой причиной женского бесплодия служит непроходимость маточных труб, чаще всего возникающая на почве перенесенных воспалительных заболеваний, главным образом гонорреи.

При выяснении причины бесплодия прежде всего необходимо исключить мужское бесплодие, причиной которого обычно является механическое препятствие к извержению семени наружу (например, резко выраженное сужение мочеиспускательного канала). Реже причиной бесплодия является азооспермия (полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте). В случаях олигоспермии (малое количество сперматозоидов), а также при астеноспермии (недостаточная подвижность сперматозоидов) необходимо микроскопическое исследование спермы (непосредственно после ее получения). Для установления влияния влагалищного секрета больной на сперматозоидов рекомендуется получить сперму путем

# р

насасывания (после полового сношения) из заднего свода или из канала шейки матки.

После обследования мужа производят обследование жены. Вначале тщательно собирают анамнез, выясняют наличие воспалительных заболеваний в прошлом, время наступления и установления менструаций, их характер (количество дней кровотечения, межменструальный промежуток, количество выделяемой крови, боли до и во время менструаций); далее двуручным гинекологическим исследованием устанавливают различные пороки развития (отсутствие матки, заращение влагалища и т. п.). Необходимо обратить сугубое внимание на наличие опухолей придатков матки.

Непроходимость труб устанавливают путем их продувания специальным прибором. Прохождение воздуха можно прослушать через брюшную стенку фонендоскопом, а также на основании появления у женщины болевых ощущений в области лопатки.

Для определения проходимости труб рекомендуется также метод сальпингографии: матку и трубы наполняют контрастной массой (липиодол, сергозин) и производят рентгеновский снимок.

Лечение. При заращении девственной плевы производят ее рассечение. При наличии конической шейки матки иногда можно получить хорошие результаты путем ее расширения или рассечения. При недоразвитии и слабой функции яичников хорошие результаты может дать лечение гормонами: в первые 10—12 дней после менструации вводить ежедневно по 5 000—10 000 единиц фолликулина, а затем ежедневно от 14-го до 22—24-го дня менструального цикла (в зависимости от длительности последнего) — по 5—10 мг прогестерона. Одновременно назначают влагалищно-крестцовую диатермию (сеансы приводят через день в количестве 15—20 процедур на курс лечения) и витамины, главным образом аскорбиновую кислоту по 0,1 два раза в день.

При непроходимости труб назначают интенсивное противовоспалительное лечение (диатермия, грязевые тампоны и т. п.), при наличии гонорреи — специфическое лечение (см. *Гоноррея*). В случае отсутствия эффекта от консервативного лечения при непроходимости труб можно прибегнуть к оперативному вмешательству.

**ВАГИНИТ, КОЛЬПИТ (VAGINITIS, COLPITIS).** ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЛАГАЛИЩА. Острый вагинит наблюдается при некоторых инфекционных заболеваниях, чаще всего в детском возрасте (цифтерия, скарлатина, корь), а также при внедрении влагалищной трихомонады. Гораздо чаще первичный вагинит вызывается механическими повреждениями (плохо подобранные, неподходящие пессарии, инородные предметы, вводимые при онанизме или в качестве противозачаточных средств, долго лежащие марлевые шарики, тампоны и пр.) или термическими (слишком горячие спринцевания), химическими (крепкие растворы при спринцеваниях). Вторичные вагиниты развиваются на почве заболеваний шейки матки (стенание раздражающих белей), при каловых и мочевых свищах, при заболеваниях нижележащих отделов. Предрасполагающими моментами является малокровие, туберкулез, инфантилизм.



**Симптомы и течение.** Бели, в свежих случаях сильное покраснение слизистой оболочки (у молодых женщин); в дальнейшем слизистая становится шероховатой, зернистой наощупь.

**Лечение.** Влагалищные спринцевания (легкие вяжущие средства, древесный уксус — одна столовая ложка на кружку воды). При наличии гнойных белей — 2% раствор марганцовокислого калия — одна столовая ложка на кружку воды. Хорошо действуют спринцевания с молочной кислотой — одна чайная ложка на кружку воды после предварительного спринцевания 2% раствором соды (для удаления слизи). Вначале спринцевания делают ежедневно (в течение двух недель), затем через каждые 2—3 дня. Когда выделения примут серозный характер, переходят к лечению тампонами (10% раствор ихтиола в глицерине). На время лечения необходимо полное запрещение половых сношений.

**ВАГИНИТ ТРИХОМОНАДНЫЙ.** Воспаление влагалища, вызванное присутствием в нем трихомонад (*trichomonas vaginalis*).

Заражение происходит обычно во время купания в стоячей воде или при подмывании некипяченой водой. Нередко во влагалище проникает кишечная трихомонада (*trichomonas intestinalis*). Иногда трихомонада вносится мужчиной во время полового акта.

**Симптомы.** Влагалище отечно, синюшно, гиперемировано. Выделения обильные, желтовато-зеленого цвета, пенные; большое количество отделяемого скапливается в заднем своде влагалища. Резкий зуд.

**Распознавание.** Диагноз ставится на основании микроскопического исследования выделений. Ватным тампоном или желобоватым зондом берут каплю выделений из заднего свода и опускают в пробирку с 5 мл теплого физиологического раствора. Для пересылки на далекое расстояние можно пользоваться мазком выделений с последующей его окраской.

**Лечение.** Стенки влагалища и матки досуха вытирают стерильным ватным или марлевым тупфером. Затем во все складки влагалища в течение 3—4 минут тщательно втирают порошок следующего состава:

Rp. Acidi borici  
Glucosae aa 3,0  
Osarsoli 0,3 M. f. pulv.  
N. 15 DS. Для  
втирания

Эту манипуляцию повторяют ежедневно в течение 10—15 дней.

Весьма часто трихомонадные вагиниты отмечаются у женщин в предклимактерическом и молодом возрасте при пониженной функции яичников. В таких случаях рекомендуется одновременно провести курс гормонотерапии путем инъекции 5 000 единиц фолликулина ежедневно в течение первых 10—12 дней после менструации (фолликулиновая фаза).

Во время лечения сухим способом спринцевание отменяют.

**ВУЛЬВИТ (VULVITIS).** **Этиология.** Механические, термические и химические раздражения (онанизм, спринцевания крепкими дезинфицирующими растворами, ожоги и др.), глисты

(острицы); диабет, мочеполовые свищи, микроинная инфекция (стрептококк, стафилококк, кишечная палочка, гонококк), трихомонада, грибок молочницы и др.

Различают острый и хронический вульвит.

**Симптомы и течение.** Острая форма вульвит а. Резко выраженная гиперемия и отечность малых губ; слизистая оболочка влагалища покрыта гнойно-фибринозным налетом; гнойные выделения; резкая болезненность и ощущение жжения и зуда в области влагалища и наружных половых органов. Хроническая форма вульвит а. Гипертрофия малых губ; краснота в окружности выводных протоков бартолиевых желез; мокнущая экзема; зуд; жжение в области влагалища и наружных половых органов.

**Лечение.** Обмывание пораженных мест 2% раствором борной кислоты, сидячие ванны с ромашкой, обмывание раствором ляписа 1:1 000. При тяжелом зуде — смазывание 2—3% раствором новокаина; мазь с 5% анестезином.

**ВУЛЬВО-ВАГИНИТ (VULVO-VAGINITIS)** наблюдается почти исключительно у девочек в период до полового созревания.

**Этиология.** Онанизм, глисты, гоноррея, трихомонада, кишечная палочка и другие осложнения после детских инфекций (корь, скарлатина, дифтерия).

**Симптомы.** Краснота, отек наружных половых органов, гнойные выделения, жалобы на боль при мочеиспускании (уретрит).

**Лечение.** В остром периоде — постельный режим, сидячие ванны из ромашки, пенициллин внутримышечно по 30 000 единиц через 4 часа; сульфаниламидные препараты в дозировке соответственно возрасту.

В хронических случаях — осторожное спринцевание (через катетер) раствором марганцовокислого калия 1:10 000, раствором ляписа 1:2 000, пенициллин, сульфаниламидные препараты, как в острых случаях.

**ВУЛЬВЫ ЗУД (PRURITUS VULVAE).** Встречается большей частью у пожилых женщин при выпадении функции яичников, нарушении обмена веществ, при нервных и психических заболеваниях, сахарной болезни.

**Симптомы и течение.** Зуд, усиливающийся по ночам. Воспаление слизистой оболочки влагалища. Расчесы наружных половых органов, садны. Обязательно исследовать мочу на сахар, а кал — на яйца глистов.

**Лечение.** 2—3% кокаиновая мазь; инъекции 5—8 мл 1% раствора новокаина; фолликулин по 10 000 единиц внутримышечно ежедневно 15—20 дней подряд. Инъекции под слизистую оболочку влагалища 10 000 единиц фолликулина через день 3—4 раза. Пудендальная анестезия. Рентгенотерапия.

Rp. Folliculini 20 000 ME 01.  
Vaselin 40,0 MDS. Мазь

Rp. Sinostroli 0,003  
01. Vaselini 40,0  
MDS. Мазь

Rp. Anaesthesini 3,0  
Streptocidi alb i 4,0 Vaselini  
40,0 MDS. Мазь

Rp. Ac. borici pulverati 4,0  
Anaesthesini 3,0 Bismuti  
subnitrici 1,0 Vaselini 50,0  
MDS. Мазь

Rp. Menthol i 1,0  
Streptocidi alb i 4,0 Vaselini  
40,0 MDS. Мазь

Лечение основного заболевания (сахарной болезни, глистной болезни, нервно-психических заболеваний).

**ВЫПАДЕНИЕ ВЛАГАЛИЩА** см. *Матки и влагалища опущения и выпадения*.

**ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ** см. *Матки и влагалища опущения и выпадения*.

**ГОНОРРЕЯ (GONORRHOEA)**. Вызывается попаданием в половые пути гонококков. Передача гонорройной инфекции взрослым женщинам происходит почти исключительно половым путем. Гонококк прежде всего поражает мочеиспускательный канал, железы преддверия влагалища и слизистую канала шейки матки; влагалище у взрослой женщины поражается гонококком крайне редко, так как плоский многослойный эпителий его и влагалищной части шейки не представляет благоприятных условий для развития гонококка. Первичное поражение влагалища наблюдается у детей, беременных и при инфантилизме. Гонококк в большинстве случаев распространяется по поверхности слизистой, но нередко имеет тенденцию проникать в строму и даже в мышечный слой. В мочеиспускательном канале обычно гонорройная инфекция долго не задерживается. Попадая в парауретральные ходы, гонококк остается здесь долгое время, что приводит к затяжному, хроническим формам заболевания. Из этих очагов инфекция нередко поступает в излеченный уже мочеиспускательный канал и дает вспышку нового острого заболевания.

Попадая на слизистую оболочку канала шейки матки, гонококк очень скоро проникает в железы и здесь сохраняется чаще и длительнее, чем в каком-либо другом участке женского мочеполового тракта. Поэтому гонорройное поражение шейки матки требует самого энергичного лечения. Из дна желез гонококки могут проникнуть в строму, образуя параглангулярные абсцессы. Пораженные железы могут закупориться и образовать закрытые полости типа ретенционных кист (так называемые ovula Nabothi) с патологическим содержимым. Токая случайно вскрытая ретенционная киста вле-

чет за собой рецидив заболевания и заражение партнера. Из шейки матки гонококк может продвинуться выше — в полость матки, трубы, яичники и на брюшину. "Поражение гонококком участков до уровня внутреннего зева шейки матки носит название гонор-реи нижнего отдела полового тракта, заболевания участков, расположенных выше уровня внутреннего зева,— гонорреи верхнего отдела полового тракта, или же восходящей гонорреи. Переходу гонококка из шейки в полость матки способствует: 1) менструация, 2) послеродовой период (раскрытие шейки, раневая поверхность матки), 3) бурное половое сношение, 4) неправильные манипуляции медицинского персонала (зондирование, спринцевание под высоким давлением в остром периоде заболевания).

**Симптомы и течение.** По характеру течения различают острые и хронические формы. При гоноррее нижнего отдела болезнь проявляется гиперемией, лейкоцитозом, обильными выделениями, в которых содержатся гонококки, расположенные внутри- и внеклеточно. К выделениям нередко примешивается кровь. Выделения обычно гнойного характера, зеленоватого цвета, с острым запахом. Больные жалуются на боли внизу живота, частые позывы к мочеиспусканию, а иногда и на зуд в наружных половых органах. В дальнейшем (через 3—4 недели) симптомы начинают постепенно ослабевать и иногда даже совсем исчезают. Во многих случаях может наблюдаться длительное подострое течение процесса с нерезко выраженными симптомами, но с наличием гонококка. При хронической форме отделяемое представляется весьма скудным, гонококки в нем обнаруживаются с большим трудом; имеются боли внизу живота, в области пахов, крестца, расстройство менструального цикла. При хронической форме в ряде случаев наблюдается объективно и главным образом субъективно бессимптомное течение заболевания. Такие больные в большинстве случаев обнаруживаются при семейном обследовании, когда они привлекаются в диспансер вследствие заражения ими мужа или партнера.

При восходящей форме гонорреи различают острую и хроническую форму. При острой форме наблюдаются сильные бели, резкие боли внизу живота и расстройства менструального цикла, сопровождающиеся обильными кровопотерями, нередко требующими госпитализации. Может наступить и длительная аме-норрея (см.). К острому воспалению придатков матки может присоединиться и пельвеоперитонит (см.) серозного и даже гнойного характера. Гонококки проникают по лимфатической и кровеносной системе в отдаленные органы и вызывают поражение эндокарда, суставов и пр. Эти осложнения могут наступить в послеродовом периоде, а также в случае половых сношений во время менструации.

**Хроническая форма** восходящей гонорреи обычно сопровождается рядом изменений в виде смещения органов, фиксации их вследствие образования спаек. При этом отмечается ряд симптомов в виде болей, белей, кровотечений.

**Распознавание.** Для постановки диагноза гонорреи, помимо анамнеза, необходимо точное бактериоскопическое или бактериологическое исследование отделяемого мочеполового аппа-

рата. Для этого берут мазки из уретры, влагалища и шейки матки. Рекомендуется брать мазки непосредственно до и после менструации. Если гонококки не обнаружены, приходится прибегать к различным методам так называемой провокации (смазывание шейки матки 3—5% раствором ляписа, внутримышечное введение гоно-вакцины).

Реакция Борде-Жангу и реакция с антигеном нередко оказывают большую помощь при диагностике.

**Лечение.** При острой свежей гоноррее назначают покой, легкую диету, категорически запрещают половые сношения, производят (осторожно!) промывание влагалища под низким давлением раствором марганцовокислого калия (1:10 000). Одновременно дают пенициллин по 50 000 единиц через 3 часа, сульфаниламидные препараты (сульфадиазин, норсульфазол и др.) через равные промежутки времени; в первый день — 8 раз по 1,0, во второй день — 6 раз по 1,0, в третий и четвертый день — 4 раза по 1,0. Для уменьшения болей — свечи с белладонной. В дальнейшем делают влагалищные ванночки из 1—2% ляписа. Уретру промывают раствором марганцовокислого калия. В хронических случаях заболевания нижнего отдела мочеполового аппарата рекомендуется также электрокоагуляция поверхностных и глубоких патологических очагов в шейке и пораженных парауретральных ходов; длительная диатермия.

В острой стадии восходящего процесса назначают покой и применяют мероприятия, направленные на приостановку маточных кровотечений (внутривенное вливание 5 мл 10% раствора хлористого кальция и одновременно аутогемотерапия по 10 мл через день, 10—12 инъекций), сульфаниламидные препараты и одновременно пенициллин. Как только острые явления проходят, назначают физиотерапевтические процедуры: вначале кварц, в дальнейшем кварц в комбинации с соллюксом. Диатермия может быть назначена исключительно в хронической стадии заболевания. В подострой и хронической стадии заболевания рекомендуется введение гоновакцины.

Хорошие результаты получены также от лечения сульфаниламидами внутрь в комбинации с местным применением пеницилина (инъекции в шейку матки 200 000—300 000 единиц через день — 5—6 инъекций).

При терапии как сульфаниламидными препаратами, так и пенициллином местное лечение (спринцевания, электрокоагуляция, ванночки и пр.) ни в коей мере не отменяется, а является обязательным.

**ДИСМЕНОРРЕЯ (DYSMENORRHOEA). БОЛЕЗНЕННЫЕ МЕНСТРУАЦИИ.** В большинстве случаев болезнь является симптомом того или иного заболевания женского полового аппарата. Дисменоррея выражается в различных формах в зависимости от причины, вызвавшей ее.

1. Самая частая форма — механическая дисменоррея — встречается у женщин, страдающих недоразвитием половых органов, рубцовым сужением шейки, а также опухолями (полипы матки, миома). При этой форме боли появляются перед на-

ступлением менструации и прекращаются на первый или второй день после ее наступления. Причина болей — препятствия для оттока менструальной крови со стороны узкой шейки или загиба матки и пр.

2. Дисменоррея на почве воспалительного процесса (хроническое воспаление труб, яичников, околоматочной клетчатки).

Боли появляются вследствие обострения хронических воспалительных процессов на почве пременструальной и менструальной гинермии в области малого таза.

3. Дисменоррея на почве неправильной функции центральной нервной системы и желез внутренней секреции.

**Лечение.** 1. При механической дисменоррее — оперативное расширение шейки матки (при отсутствии воспалительного процесса в половой сфере и особенно гонорреи), общее укрепляющее лечение. При инфантилизме — введение гормонов (фолликулин, прогестерон). Хорошие результаты (в смысле излечения) дают роды.

2. При дисменоррее на почве воспалительных процессов — лечение основного заболевания: тепловая, рассасывающая терапия, диатермия, грязевые тампоны, лечение на курортах (Саки, Ессентуки, Евпатория и др.).

3. При дисменоррее на почве расстройств функции центральной и эндокринной и вегетативной нервной системы рекомендуются: в первые 10 дней после начала менструаций небольшие дозы фолликулина (1 000—2 000 единиц ежедневно внутримышечно) и значительные дозы прогестерона (с 14-го по 20—22-й день менструации по 8—10 мг ежедневно внутримышечно); бром с кофеином внутрь.

При дисменоррее, независимо от ее этиологии, во многих случаях хорошие результаты дает атропин по 0,5 мг (0,0005) в пилюлях 3 раза в день или порошки по следующей прописи:

Rp. Extr. Belladonnae 0,02 Asp kin i  
Pyramidoni Bromurali aa 0,3 Coffeini  
natrio-benzoici 0,1 M. f. pulv. D. t. d. N.  
12 D6. 2—3 раза в день по 1 порошку

Хорошие результаты дают теплые микроклизмы из настоя ромашки с антипирином и пирамидоном (по 0,3).

При резко выраженной дисменоррее боли можно купировать внутримышечным введением 1 мл адреналина (1:1000) Длительное время адреналин вводить нельзя.

В некоторых случаях получается хороший эффект в результате применения эфедрина по 0,05 два раза в день.

Перед назначением курса эфедрина надо дать его для пробы с целью выяснения реакции организма на этот препарат,

**КИСТА ЯИЧНИКА (CYSTOMA OVARII).** Новообразование яичника вследствие пролиферации его слизистой ткани (оластома). Две трети всех новообразований яичника представляют собой п с е в д о м у ц и н о з н ы е (железистые) кисты, чаще всего односторонние, значительных размеров. Опухоль чаще многокамерная, не сопровождается асцитом. Серозная киста развивается из обоих яичников (двусторонние кисты) и бывает небольшой величины (редко больше мужского кулака); на внутренней поверхности оболочки кисты имеются папиллярные разрастания.

В случае разрыва серозной кисты во время операции и излития ее содержимого в брюшную полость наблюдается имплантация сосочков на брюшине, сальнике, на серозном покрове кишечника; в дальнейшем отмечается развитие значительного асцита и метастазов на сальнике, брюшине.

Содержимое дермоидных кист — кожа, волосы, кости, зубы, сальные железы.

Кисты связаны с маткой посредством ножки, состоящей главным образом из собственной связки яичника.

**Симптомы.** Небольшие кисты могут не давать никаких симптомов. При наличии длинной ножки и большой подвижности кисты может наступить перекрут ножки кисты (одно- и многократный перекрут); при этом нарушается питание кисты, киста некротизируется, наступают резкие боли, явления раздражения брюшины, иногда высокая температура (острый живот). В большинстве случаев перекрут наступает внезапно.

**Лечение** кист оперативное. В случае перекрута требуется экстренная операция.

**КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.** Наблюдаются при угасании функции яичников вследствие возрастных изменений (после 45—50 лет), после операции удаления яичников, после облучения рентгеновыми лучами (рентгеновская кастрация), а также при некоторых эндокринных заболеваниях.

**Симптомы и течение.** Некоторые женщины отмечают в климактерическом периоде только незначительно» недомогание, другие страдают головными болями, жалуются на приливы (покраснение лица, потливость, сердцебиение). Все эти явления вскоре проходят, но могут повторяться по нескольку раз в день и нередко ночью. Иногда наблюдается повышение кровяного давления. Работоспособность падает. Климактерические расстройства иногда проходят через 1—2 года после прекращения менструаций, в других же случаях продолжают в течение многих лет.

**Лечение.** Основное лечение — гормональное (применение фолликулина). Фолликулин назначают по 10 000 единиц в течение 10—15 дней подряд.

Однако назначать всем женщинам, страдающим климактерическими расстройствами, фолликулин нецелесообразно, так как в некоторых случаях это не приносит пользы, а иногда приводит к ухудшению общего состояния.

Большое облегчение приносят горячие ножные ванны, общие теплые ванны, препараты брома, валерианы.

Вр. Papaverini

Luminali aa 0,015

Pyramidon i

Natrii bromati aa 0,3

M. f. pulv. D. t. d. N. 12

DS. 3 раза в день по 1 порошку

Вр. Papaverini 0,02

Aspirin i

Phenacetini aa 0,3

Bromurali 0,4

M. f. pulv. D. t. d. N. 12

DS. 2 раза в день по 1 порошку

Вр. Natrii bromati .1,5 Pyramidoni 0,8 Coffeini natriobenzoici 0,6 Aq. destill. 200,0 MDS. 3—4 раза в день по 1 столовой ложке •

Рекомендуется также воротник по Щербак с бромистым натрием и хлористым кальцием.

При наличии опухоли в половом аппарате всякое гормональное лечение и электролечение строго противопоказаны: в этих случаях ограничиваются применением только препаратов брома и валерианы и регулированием общего режима.

**КОЛПИТ** см. *Vaginit.*

**КОНДИЛОМЫ ОСТРЫЕ (CONDYLOMA ACUMINATA).** Мелкие папиллярные, бородавчатые разрастания на промежности, наружных половых органах, на слизистой влагалища, шейке матки.

**Этиология.** Хронический воспалительный процесс шейки и влагалища с обильными выделениями; отсутствие элементарных гигиенических мероприятий.

**Симптомы и течение.** Выделение, зуд в области влагалища, промежности. При образовании большой группы кондилом они могут занимать большое пространство. Во время беременности кондиломы быстро разрастаются.

**Лечение.** При обычных кондиломах прижигание резорциновой пастой. Хирургическое удаление ножницами или ножом с последующей присыпкой порошком резорцина. Электрокоагуляции. При обширном распространении кондилом рекомендуется оперативное лечение в несколько приемов (2—3).

Rp. Resorcini 5,0

Vasellini

Glycerin! aa 10,0

MDS. Наружное

**МАСТИТ (MASTITIS), ГРУДНИЦА. ВОСПАЛЕНИЕ ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.** Этиология. Внедрение инфекции (стафилококк, стрептококк) большей частью происходит через трещины сосков во время кормления грудью; однако может встречаться и у небеременных.

**Симптомы и течение.** Лихорадочное состояние, высокая температура, нередко ознобы; резкие боли и чувство напряжения в грудной железе. Пальпацией удастся определить уплотнение и резкую болезненность ограниченного участка; иногда флюктуацию.

**Лечение.** Сухая поддерживающая повязка, ограничение питья; слабительные соли 25—30 г (отвлечение жидкости); внутрь сульфаниламидные препараты по 1 г 4—5 раз в день; лед на грудную железу (кормления больной грудью не отменять!). В случае отсутствия эффекта — согревающие водные или спиртовые компрессы. При обнаружении инфильтрата рекомендуются инъекции пенициллина вокруг инфильтрованного участка грудной железы по 200 000 ед. нгц, растворенных в 8—10 мл 0,5% раствора новокаина, 2 раза в день с промежутками в 6 часов.

При обнаружении фокуса размягчения — диагностическая пункция; посев содержимого; радиальный разрез подальше от соска; i. ложение контрапертур; дренирование марлевыми полосками, мочеными в пенициллине (50 000 единиц, растворенных в 30—50 мл i. криологического раствора).

**МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ (DESCENSUS PROLAPSUS UTERI ET VAGINAE).** Причины. Понижение общего тонуса и ослабление мускулатуры тазового дна, слабость связочного аппарата матки, разрыв промежности с расхождением леваторов (незащитные разрывы промежности после родов).

**Патогенез.** Выпадение влагалища и матки может быть полным или частичным. При опущении и выпадении передней стенки влагалища опускается мочевого пузыря (cystocelle); при опущении и выпадении задней стенки влагалища опускается передняя стенка прямой кишки (rectocelle). При выпадении влагалища и матки, вследствие трения выпавших частей о бедра и одежду, а также нарушения трофических процессов в выпавших тканях, образуются пролежни и изъязвления, к которым нередко присоединяется инфекция.

**Симптомы.** Чувство тяжести и опущения внизу живота (ощущение присутствия инородного тела в стоячем положении, в особенности при ходьбе), учащение мочеиспускания (cystocelle), запоры (rectocelle).

**Течение и осложнения.** Опушение матки и влагалища с течением времени прогрессирует. При полном выпадении матки и влагалища — отек, гипертрофия, образование пролежней.

**Лечение.** Пролежни: тампоны с мазью Вишневского, тампоны с пеницилиновой мазью. Новокаиновая блокада: вокруг участка, пораженного пролежнем, инъцируют 50 000 единиц пенициллина, растворенных в 10 см<sup>3</sup> 0,25% раствора новокаина; блокада производится через день; всего назначают 8—10 сеансов.

После эпителизации места пролежня лечение проводят еще в течение 2—3 недель, так как, несмотря на эпителизацию, в строю остаются еще участки инфильтрации и ранняя операция не дает надлежащего эффекта вследствие плохого заживления. Поэтому операцию после закрытия дефекта пролежня нужно производить

не ранее чем через один месяц, применяя в это время соответствующее лечение.

Лечение опущения и выпадения влагалища и матки оперативное.

Ношение пессариев является паллиативом, и длительное их применение ведет к образованию пролежня.

**Профилактика.** Тщательное послеродовое зашивание разрывов промежности; ношение бандажа до и после родов; лечебная физкультура во время беременности и в послеродовом периоде; спортивные упражнения по совету врача.

**МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ.** Маточные кровотечения во время беременности и родов наблюдаются при выкидышах (см. *Аборт*), при внематочной беременности (сл.), пузырном заносе (см.), преждевременной отслойке нормально прикрепленного детского места (см.), при предлежании детского места (см.). Маточные кровотечения вне беременности являются симптомом гинекологических заболеваний: доброкачественных, злокачественных опухолей, воспалительных заболеваний, а также нарушение функции нервной и эндокринной системы и др.

Различают две основные формы маточных кровотечений: 1) метроррагии и 2) метроррагии.

**Метроррагии** — маточные кровотечения, связанные с менструальным циклом: менструация начинается в срок, но не прекращается, как обычно, через 4—5 дней, а продолжается 8—10—12 дней. При следующей менструации, наступающей также в срок, вновь повторяется такая же картина. Таким образом, количество дней кровотечения при менструации увеличивается, а межменструальный промежуток укорачивается. Метроррагии наблюдаются при фибромиомах матки, воспалительных процессах женской половой сферы, некоторых формах инфантилизма (недостаточная сократительная способность матки), а также при заболеваниях сердца (застойные явления в малом тазу) и др.

**Метроррагии** — маточные кровотечения, не связанные с менструальным циклом, нерегулярные, бесзрядочные, различной интенсивности (сильные и слабые), они продолжаются неопределенное время, затем следует некоторый промежуток времени без кровотечений, в дальнейшем сменяющийся периодом беспорядочных кровотечений. Метроррагии наблюдаются при раке матки, подслизистой миоме, тяжелой форме воспаления слизистой оболочки матки и др.

Разновидностью метроррагии является геморрагическая метроррагия, при которой менструация может отсутствовать иногда 1/2—2, даже 3 месяца, а затем может начаться беспорядочное маточное кровотечение, также не связанное с менструальным циклом. Причиной заболевания является неправильная функция яичников. Геморрагическая метроррагия наблюдается главным образом в молодом возрасте (15—20 лет), во время установления нормального ритма менструаций и перед наступлением климакса, во время угасания менструальной функции.

**Распознавание.** Чрезвычайно важно для назначения соответствующего лечения выявление причин заболевания. Необходимо тщательно собрать анамнез, выяснить особенности и харак-

»ер кровотечений, а также наличие в прошлом воспалительных заболеваний женской половой сферы, опухолей и неполовых заболеваний (сердца, легких, почек, нервной системы и т. п.). Затем следует гинекологическое исследование: осмотр зеркалами для выявления наличия эрозии (подозрение на рак), полипа, рождающейся фибромиомы, и внутреннее исследование: определяют состояние шейки, величину, форму, консистенцию, подвижность матки, наличие воспалительных опухолей придатков матки и т. п. При подозрении на рак шейки или тела матки обязательно производят в срочном порядке биопсию и пробное выскабливание с последующим микроскопическим исследованием.

**Лечение.** Лечение основного заболевания. При наличии воспалительного процесса матки и ее придатков — внутривенное вливание 10% раствора хлористого кальция в количестве 5—10 мл, производимое через день; аутогемотерапия через день по 10 мл. Рекомендуется сочетать следующие манипуляции: сначала ввести в вену 5—10 мл 10% раствора хлористого кальция, тут же наложить жгут на руку, набрать 10 мл крови и ввести внутримышечно в ягодичу. Хорошие результаты дает внутримышечное введение маммо-физина 1—2 раза в день по 1 мл. При незначительных кровотечениях в климактерическом возрасте назначают маммин по 1,0 два-три раза в день в течение 3—4 недель; при значительных кровотечениях — переливание крови в количестве 200—400 мл при низком проценте гемоглобина (ниже 50) и длительных хронических незначительных кровотечениях — многократное переливание небольших (60—80 мл) доз крови.

При геморрагической метроррагии производят выскабливание слизистой оболочки матки как с целью диагностики этиологии данного заболевания, так и с лечебной целью. После выскабливания ежедневно в течение 10 дней внутримышечно вводят 5—10 мл прогестерона. При отсутствии эффекта в результате применения консервативной терапии и угрожающем жизни больной состоянии в некоторых случаях прибегают к удалению матки.

**МЕТРИТ (METRITIS). ВОСПАЛЕНИЕ МЫШЦЫ МАТКИ.**

1. Острый метрит (metritis acuta). **Этиология.** Глубокое внедрение инфекции при эндометрите в строму и за пределы ее обычно при инфекционных септических заболеваниях после родов и аборта.

**Симптомы и течение.** Матка несколько увеличена, отечна, болезненна; нередко обнаруживаются обильные выделения гнойно-серозного характера; маточные кровотечения типа мено- и метроррагии (си.); при гинекологическом исследовании нередко отмечается и отечная эрозированная шейка, а также воспаление придатков матки (труб и яичников). Высокая температура.

**Лечение.** Покой, постельный режим, лед на низ живота. При болях — свечи с белладонной и пантопоном, сульфаниламидные препараты по 1 г 4—5 раз в день, пенициллин по 50 000 единиц 6 раз в течение суток; внутривенно 6—8 мл 10% раствора хлористого кальция; аутогемотерапия.

2. Хронический метрит (metritis chronica). **Этиология.** Переход острой формы в хроническую, расстройство гормональной

функции яичника (персистирующий фолликул); расстройство кровообращения при неправильных положениях (особенно при ретрофлексии) матки и др.

**Симптомы и течение.** Боли внизу живота и в крестце; выделения; маточные кровотечения типа мено- и метроррагии.

При внутреннем исследовании матка, нередко и шейка, плотны; матка болезненна, особенно при комбинации метрита с хроническим воспалением придатков.

При постановке диагноза исключить беременность (наблюдение 1—2 месяца за величиной матки, в трудных случаях — реакция Ашгейм-Цондека).

**Лечение.** В-, период кровотечения — постельный режим; инъекции маммофизина по 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день, препараты маточных рожков, стиптицин (0,05 три-четыре раза в день).

При отсутствии кровотечения, повышенного лейкоцитоза, ускоренной РОЭ — освещение живота кварцевой лампой, диатермия (вначале абдоминально-сакральная, а затем вагинально-сакральная), в дальнейшем грязевое лечение.

**МЕТРОЭНДОМЕТРИТ см. Эндометрит.**

**МИОМА, ФИБРОМИОМА МАТКИ (MYOMA, FIBROMYOMA UTERI).** Доброкачественная мышечно-соединительнотканная опухоль матки. В зависимости от превалирования в опухоли мышечной или соединительной ткани, что определяется при исследовании, главным образом по консистенции матки, опухоль носит название в первом случае миомы, во втором — фибромиомы. По месту расположения различают межмышечные, подслизистые, подсерозные и шеечные миомы (фибромиомы). Форма матки при фибромиомах бывает самая различная: круглая при межмышечной фибромиоме (миоме), бугристая при наличии нескольких фиброзных узлов под серозной оболочкой. Иногда фиброзный узел отходит от матки на ножке. Такой узел может перекручиваться.

Быстрый рост матки и опухоли в молодом возрасте может быть обусловлен комбинацией опухоли с беременностью. В более пожилом возрасте, в особенности в климактерическом, он должен вызвать подозрение на злокачественное перерождение опухоли.

Вторичные изменения фибромиом: 1) некроз опухоли (нарушение питания, травматизация опухоли во время родового акта) — опухоль становится мягкой консистенции, наступают внезапные боли; 2) (картина, напоминающая септикопиемию) проникновение инфекции из полости матки, в особенности при подслизистой фибромиоме; 3) саркоматозное перерождение, быстрый рост (климакс!); 4) перекрут опухоли на ножке.

Фибромиома матки нередко осложняет течение беременности и родов. Большая опухоль, расположенная в полости малого таза, делает в некоторых случаях невозможным прохождение головки плода по родовым путям. Такие беременные должны быть направлены в родильный дом за 10—15 дней до предполагаемого срока родов и помещены в палату (отделение) беременных. Во время родов возможны кровотечения в послеродовом и послеродовом периоде.

**Симптомы.** Основным симптомом фибромиомы матки является маточное кровотечение, чаще типа меноррагии. При наличии большой опухоли, давящей на мочевой пузырь, наблюдается частое мочеиспускание. При давлении на прямую кишку отмечаются запоры механического характера. В случаях шеечного расположения миомы в результате сдавления канала шейки матки больные при наступлении менструации испытывают резкие боли вследствие затруднения в оттоке менструальной крови. Боли при наличии подсероз-цэп фибромы или фибромы на ножке указывают на начальные явления перекрута, некроза.

**Распознавание** основано на анамнезе и результатах гинекологического исследования (большая плотная матка шаровидной или бугристой формы, наличие узлов на ножке, обнаружение рождающейся фибромы при осмотре зеркалом).

**Лечение.** Небольшие фибромы, протекающие без симптомов (нормальный менструальный цикл, отсутствие болей, отсутствие жалоб на функцию прямой кишки и мочевого пузыря), не требуют лечения. Больная должна находиться под наблюдением консультации и показываться врачу каждые 3 месяца.

При наличии небольшой, но сопровождающейся кровотечениями фибромы следует испробовать консервативное лечение: ионизацию грудных желез (аутомамминизацию) через день (15 сеансов), инъекции маммофизина по 1 мл через день (на курс 15 инъекций); во время менструаций инъекции производятся ежедневно. В случае отсутствия эффекта прибегают к операции или к лечению рентгеновыми лучами. В молодом возрасте предпочтительнее произвести операцию, чтобы сохранить функцию яичников. При наличии беременности рентгеновское облучение противопоказано. Необходимо выждать до окончания срока беременности, сделать кесарево сечение, извлечь живого ребенка и тут же произвести ампутацию матки. В климактерическом возрасте, в особенности при нарушении сердечной\* деятельности, наличии эмфиземы и т. п., назначают лечение рентгеновыми лучами. Однако перед этим необходимо произвести все исследования (в особенности выскабливание и микроскопическое исследование соскоба) для того, чтобы убедиться, что в данном случае не имеется злокачественного новообразования.

**НЕДЕРЖАНИЕ, НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ.** Недержание мочи наблюдается при опущениях и выпадениях влагалища и матки, при ослаблении сфинктера и частичном нарушении его целостности в связи с родовой травмой, а также при нарушении функции нервной системы. Недержание мочи является следствием мочеполювых свищей.

**Распознавание и этиология** основываются на анамнезе и детальном гинекологическом, урологическом и неврологическом обследовании.

**Лечение.** При опущении, выпадении влагалища, матки производят пластические операции на промежности и передней стенке влагалища, операцию уретропластики. Общеукрепляющее лечение при неудержании мочи нервной этиологии. При иудержании мочи (свищи) — оперативное лечение.

I»

**ОПУЩЕНИЕ ВЛАГАЛИЩА** см. *Матки и влагалища опущения и выпадения.*

**ОПУЩЕНИЕ МАТКИ** см. *Матки и влагалища опущения и выпадения.*

**ПАРАМЕТРИТ (PARAMETRITIS).** Воспаление околосматочной клетчатки редко встречается изолированно. Обычно встречается в комбинации с заболеванием матки и ее придатков или соседних органов, расположенных в полости малого таза.

Внедрение инфекции происходит через надрывы в области шейки, в нижнем маточном сегменте, главным образом по лимфатическим путям и через лимфатические щели, особенно при септических заболеваниях после родов и аборта.

Воспалительный процесс околосматочной клетчатки наблюдается нередко при раке, саркоме матки, при парапроктите, перитифлите, аппендиците.

**Симптомы и течение.** Резкие боли внизу живота; высокая температура со значительными ремиссиями по утрам; озноб; расстройство мочеиспускания и дефекации (частое болезненно\* мочеиспускание, запоры, метеоризм); рвота.

**Распознавание.** При внутреннем исследовании задний и боковой своды уплощены или выпячены; прощупывается плотный инфильтрат, нередко доходящий до стенок таза.

Инфильтрат может быть односторонним, двусторонним; иногда он циркулярно охватывает всю матку; придаток отдельно не прощупывается.

(бласть инфильтрата резко болезненна, консистенция пастозная. В некоторых случаях ощущается флюктуация (экссудат или гной).

При параметрите рекомендуется, в особенности при наличии высокой температуры, не ограничиваться однократным внутренним исследованием для того, чтобы во-время определить флюктуацию, наличие гноя (устанавливается пункцией) и провести своевременное лечение (кольпотомия).

**Лечение.** В острой стадии назначают абсолютный покой, лед на низ живота, молочно-растительный стол, обезболивающие свечи, сульфаниламидные препараты по 1 г 6 раз в сутки; пенициллин внутримышечно по 50 000 единиц через 3 часа; внутривенно хлористый кальций (5—8 мл 10% раствора ежедневно); аутогемотерапию.

При обнаружении флюктуации прибегают к пункции и кольпотомии с последующим дренированием. Введение в область параметрия 200 000—300 000 единиц пенициллина через день.

В хронической стадии назначают торячие спринцевания; клизмы из ромашки, в которые прибавляют столовую ложку 20% водного раствора ихтиола; кварц, соллюкс на низ живота; вагинально-сакральную диатермию.

В дальнейшем применяют интенсивную грязевую терапию (вагинальные грязевые тампоны, грязевые «труссы»).

**ПЕЛЬВЕОПЕРИТОНИТ (PELVEOPERITONITIS). ВОСПАЛЕНИЕ БРЮШИНЫ МАЛОГО ТАЗА.** Этиология и патогенез. Септические заболевания после родов и абортов (стрептококк, стафилококк, кишечная палочка); гонококковая инфекция,

прогрессирующие воспалительные заболевания придатков МЕТКИ (труб, яичников) вне беременности. Проникновение инфекция через- матку, трубы, по кровеносной, лимфатической системе из виеполовых очагов инфекции.

**Симптомы и течение.** Высокая температура, частый пульс, озноб, общее плохое самочувствие, резкие боли в животе, вздутие живота и напряжение брюшных стенок. Болезненность ощущается больше внизу живота. При гнойном экссудате в заднем дугласовом пространстве нередко скапливается гной.

При нелъвеоперитоните, вызванном гонококковой инфекцией, переход в диффузный перитонит наблюдается редко; стрептококковые же пельвеоперитониты нередко переходят в общий перитонит.

При скапливании гноя в заднем дугласовом пространстве гной может самопроизвольно опорожниться в мочевоц пузырь, прямую кишку или во влагалище.

**Лечение.** Покой, лед на низ живота, болеутоляющие свечи; молочно-растительная диета; сульфаниламидные препараты по 1 г 6 раз в день; пенициллин внутримышечно по 100 000 единиц через 3 часа; физиологический раствор или 5% раствор глюкозы под кожу 1—2 раза в день по 1 л; сердечные средства.

При выпячивании заднего свода, ощущении флюктуации в заднем дугласовом пространстве — пункция и кольпотомия.

В дальнейшем, после снижения температуры, аутогемотерапия — по 10 мл собственной крови через 2 дня на третий; согревающие компрессы на живот; освещение кварцевой лампой.

Более интенсивное лечение (диатермия, грязевая терапия) назначают через 2—3 месяца после установления нормальной температуры.

**ПЕРЕКРУЧИВАНИЕ НОЖКИ ОПУХОЛИ.** **Симптомы и течение.** Резкие боли внизу живота, явления раздражения брюшины, тошнота, рвота, высокая температура.

Болезнь наступает внезапно, нередко ночью или утром (через 10—12 часов иосле перекута, т. е. после того, как\*начался н е-кроз перекученной опухоли фиброзного узла или кисты); однако боли могут наступить и непосредственно после перекута. При нарушении целостности сосудов и наличии кровоизлияния в полость кюты — признаки внутреннего кровотечения.

**Лечение.** При острых явлениях — немедленная операция. При частичном перекучивании, при нерезко выраженных симптомах, при небольшой величине опухоли —постельный режим; больная должна лежать на боку, противоположном стороне расположения опухоли; болеутоляющие свечи. В дальнейшем — операция в холодном периоде по поводу основного заболевания.

**ПЕРИТОНИТ** см. *Хирургические болезни,*

**ПИЕМИЯ** см. *Сепсис.*

**ПОЛИП МАТКИ (POLYPUS UTEEI).** Исходит из слизистой оболочки тела матки или шеечного канала. Различают слизистые, фиброзные, адеиоматозные полипы, а также так называемые плацентарные полипы, образовавшиеся из остатков детского места после родов или абортов (см.).

Полипы слизистой оболочки канала шейки матки обычно небольших размеров и хорошо видны при осмотре шейки зеркалами. Однако в некоторых случаях, когда имеется подозрение на наличие полипа и не удастся его обнаружить, рекомендуется произвести осмотр во время менструации, когда полип опускается ниже — ближе к наружному отверстию маточного зева.

Полип тела матки постепенно вытягивается, свисает на ножке и становится видим при осмотре зеркалами, после того как он достиг значительных размеров.

При полипе как матки, так и шейки в большинстве случаев наблюдается нарушение менструального цикла (длительные, обильные кровотечения).

При полипе, выходящем за уровень наружного зева, нередко наблюдается кровотечение после полового сношения.

При ущемлении полипа наступает некроз, нередко осложняющийся присоединившейся инфекцией.

**Лечение** хирургическое. Мелкие полипы откручивают, крупные удаляют путем рассечения ножки.

После удаления полипа тут же следует выскаблить слизистую тела матки (возможность добавочных полипов выше обнаруженного полипа).

Обязательно гистологическое исследование удаленного полипа и соскоба (возможность злокачественного новообразования!).

**ПОЯСНИЧНЫЕ ВОЛИ** наблюдаются при воспалительных заболеваниях женской половой сферы (аднексит, параметрит— см.), неправильных положениях матки (фиксированная ретрофлексия, опущение, выпадение матки и влагалища), при экстрагенитальных заболеваниях, пиэлите, нефрите, а также при различных аномалиях позвоночника: лордоз, сакрализация, люмбализация позвоночника; при ревматизме, нарушении обмена веществ (подагра) и при невралгиях.

**Распознавание.** Каждый раз необходимо установить истинную причину болей, для чего, помимо гинекологического обследования, надо произвести рентгенологическое, неврологическое и общее обследование всего организма больной.

**Лечение** в зависимости от причины заболевания. При опущении и выпадении влагалища и матки — оперативное лечение, при воспалительных заболеваниях женской половой сферы — противовоспалительное, при ревматизме и подагре — соответствующее лечение (см.).

Хорошие, но, к сожалению, временные результаты дают клизмы с ромашкой и антипирином (0,5 на одну клизму) и ионизация новокаином.

**РАК МАТКИ (CANCER UTERI).** Различают рак шейки матки и рак тела матки. Рак шейки матки встречается значительно чаще (в 7—8 раз), чем рак тела матки. Рак матки встречается чаще в пожилом возрасте, однако он может встречаться и в молодом, и даже в раннем детском возрасте.

Раковая опухоль, разрастающаяся из шейки матки, может иметь тенденцию к росту или в сторону влагалища- (эк з офит па я



форма), или в сторону канала шейки, т. е. по направлению к телу матки (эндотитная форма).

Различают также папиллярную форму рака шейки матки, когда опухоль состоит как бы из мелких сосочков, которые принимают вид цветной капусты, и кратерообразную, когда раковая опухоль изъязвляется, покрывается серым налетом и имеет углубление в центре в виде язвы, которую необходимо дифференцировать с сифилитической и туберкулезной язвой.

Если больная не лечится, раковая опухоль распространяется на соседние органы — околоматочную клетчатку, прямую кишку, мочевой пузырь и прорастает эти органы с образованием пузырно-влагалищных и прямокишечно-влагалищных свищей.

Образуются метастазы в подчревные, подвздошные, поясничные, аортальные железы, а также в печень, легкие и другие органы.

Рак тела матки распространяется так же, но несколько медленнее, чем рак шейки матки.

**Симптомы.** Первым наиболее ранним симптомом являются маточные кровотечения.

Появление крови из половых путей в климактерическом возрасте, когда у женщины уже в течение 1—1½ лет прекратились менструации, является моментом, заставляющим произвести все необходимые исследования для решения вопроса о наличии или отсутствии ракового новообразования.

Кровотечения, наступающие после половых сношений, весьма подозрительны в отношении рака шейки матки.

Беспорядочные атипические маточные кровотечения с нарушением менструального цикла у молодой женщины являются основанием для детального обследования ее половой сферы, точно так же как кровянистые выделения после гинекологического исследования.

Вторым симптомом рака матки являются выделения. Вначале выделения могут быть водянистыми жидкими, не очень обильными даже тогда, когда еще нет нарушений в менструальном цикле и нет кровянистых выделений в климактерическом возрасте. Но в дальнейшем к ним присоединяется примесь крови, выделения становятся сукровичными, цвета мясных помоев, с резким неприятным запахом. Такого характера выделения говорят о начавшемся распаде опухоли.

Третий симптом — боли — появляется очень поздно — тогда, когда раковая опухоль распространилась за пределы шейки или тела матки. Такие случаи рака являются уже неоперабельными.

Необходимо отметить, что симптом истощения, резкого похудения при раке матки может отсутствовать, и наружный вид больной нередко весьма обманчив.

**Распознавание.** При малейшем подозрении на рак матки необходимо собрать очень тщательный и детальный анамнез, обращая особое внимание на указанные выше симптомы. Обязателен осмотр зеркалами, исследование через влагалище, а также через прямую кишку.

При подозрении на рак шейки матки делают биопсию, при подозрении на рак тела матки — пробное выскабливание с последующим гистологическим исследованием.

При подозрении на рак шейки матки, помимо биопсии, рекомендуется сделать пробное выскабливание слизистой тела матки (возможность рака тела матки!).

**Лечение.** Радикальная операция с последующей рентгенотерапией; некоторые хирурги применяют предварительную, до операции, рентгенотерапию. Опасение, что после проведения курса рентгенотерапии операция осложнится, вследствие большей кровотоочивости тканей, лишено оснований. Возможность оперативного вмешательства зависит главным образом от степени разрастания ракового процесса.

Различают следующие пять стадий распространения рака матки: 1) раковым процессом поражена только шейка или только тело матки; матка подвижна, параметрий свободен; оперативное вмешательство вполне возможно; 2) матка подвижна, околоматочная клетчатка уплотнена, но инфильтрат в клетчатке не доходит до стенок таза (возможно не раковое поражение, а воспалительный процесс в клетчатке) — операция технически трудна, но возможна; 3) матка фиксирована, клетчатка инфильтрирована, плотный инфильтрат доходит до стенок таза — форма неоперабельная; показано лучевое лечение (радий- и рентгенотерапия); 4) раковый процесс распространился на соседние органы — мочевой пузырь, прямую кишку — с образованием свищей; клетчатка с пораженным раковым процессом органом составляет сплошной конгломерат, выполняющий всю полость малого таза; 5) рецидив ракового процесса. При последних двух формах как оперативное, так и лучевое лечение не показано. Рекомендуются меры для облегчения страданий больных, главным образом введение морфина 2—3—4 раза в сутки для снятия мучительных болей.

**Профилактика.** Ознакомление населения с ранними признаками рака; разъяснение необходимости раннего обращения к врачу, главным образом при наличии маточного кровотечения; проведение профилактических осмотров женщин, независимо от возраста, для выявления не только ранних стадий рака, но и воспалительных заболеваний полового аппарата, для привлечения этих больных в женскую консультацию и проведения систематического лечения.

**СВИЩИ (FISTULAE).** Чаще встречаются пузырно-влагалищные и прямокишечно-влагалищные свищи, реже — мочеточничко-влагалищные, мочеточничко-шеечные, уретро-влагалищные и пузырно-шеечные свищи.

**Причины.** Родовая травма; узкий таз, длительный вставочный период головки, прижатие мягких родовых путей к костям таза с последующим некрозом тканей; повреждение мочевого пузыря при перфорации головки плода, при применении акушерских щипцов.

Свищи могут образоваться как осложнение во время и после гинекологических операций (нарушение целостности мочевого пузыря и мочеточников при операции экстирпации матки), травма моче-

точников, мочевого пузыря, прямой кишки с образованием некроза после операции по поводу рака матки.

Свищи могут образоваться после интенсивного облучения радиом при неумелом и неправильном применении препаратов радия и т. п.

При нарушении целостности тканей во время операции и родов свищи появляются непосредственно после родов или операции.

Свищи, образовавшиеся вследствие некроза тканей, могут появиться через 8—10—12 дней после родов или операции.

Лечение оперативное.

СЕПСИС см. *Хирургические болезни*.

**ТРОМБОФЛЕВИГ** см. *Хирургические болезни*.

**УЩЕМЛЕНИЕ МАТКИ (INCARCERATIO UTERI)** наблюдается главным образом при беременности и реже при опухолях матки вне беременности.

Если беременность сочетается с резким перегибом матки кзади (*retroflexio uteri gravidi*), фиксированной спайками, беременная матка не может выйти из полости малого таза и с развитием беременности плотно вколачивается в малый таз. Таким образом, наступает ущемление матки.

Если вне беременности из задней стенки резко загнутой кзади матки исходит фиброзная опухоль, то по мере роста она также может вколотиться в малый таз. Таким образом, вместе с маткой ущемляется и опухоль.

**Симптомы и течение.** Резкие боли внизу живота, в пояснице; запоры вследствие сдавления прямой кишки телом матки или опухолью. Шейка матки упирается в симфиз и в области *trigoni* прижимает к нему мочевого пузырь, вследствие чего происходит задержка мочеиспускания или затруднение в мочеиспускании. При этом создается опасность некротизации детрузора мочевого пузыря и образования пузырно-влагалищного или уретро-влагалищного свища.

**Лечение.** Опорожнить катетером мочевого пузырь. Введенными в задний свод двумя пальцами осторожно вывести матку из полости малого таза.

В случае неудачи надо произвести эти манипуляции под наркозом лишь в редких случаях прибегнуть к оперативному вмешательству.

**ЭНДОМЕТРИТ (ENDOMETRITIS). ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ.** Вызывается стрептококком, стафилококком, кишечной палочкой, гонококком, туберкулезной палочкой.

**Острая форма** эндометрита встречается после родов и аборта. Вне беременности — как восходящий процесс при заболевании гонореей, при восходящей инфекции другой этиологии (стрептококк, стафилококк, кишечная палочка), а также как следствие нисходящей инфекции (туберкулез, грипп).

При острой форме эндометрита отмечается повышение температуры, резкие боли внизу живота, обильные выделения, часто с примесью крови, при септической форме — ознобы, лейкоцитоз, ускорение РОЭ, сдвиг влево формулы белой крови.

При внутреннем исследовании матка несколько увеличена, отечна, болезненна при пальпации; нередко можно встретить комбинацию с воспалением шейки матки, миометрия и придатков.

**Хроническая форма** эндометрита по существу является дальнейшим развитием острой формы.

При хронической форме эндометрита матка умеренно увеличена, плотна, часто ограничена в подвижности вследствие наличия спаек (см. *Аднексит и параметрит*), несколько болезненна. Воспалительный процесс нередко распространяется на мышечный слой матки (см. *Метрит*).

**Лечение.** В острой стадии: постельный режим, лед на низ живота, спорынья, питуикрин или маммофизин по 1 мл под кожу, 5—10 мл 10% раствора хлористого кальция внутривенно и одновременно аутогемотерапия 8—10 мл через день, 8—10 инъекций.

При септической форме эндометрита — пенициллин внутримышечно через 3 часа по 50 000—100 000 единиц, сульфаниламидные препараты по 1 г 6 раз в день.

**В хронической стадии:** кварц, соллюкс на низ живота, влагалищно-крестцовая диатермия, грязевое лечение.

**ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ (EROSIO COLLI UTERI).** Образование эрозии — результат нарушения целостности и разрушения покровного плоского эпителия шейки матки с обнажением стромы и развития воспалительного процесса на этом участке вследствие внедрения микробов (стрепто- и стафилококк, гонококк).

Эрозия может быть вызвана также внедрением туберкулезной палочки, бледной спирохеты (туберкулезная, сифилитическая эрозия или язва).

Эрозия может образоваться вследствие роста новообразования (рак!).

Длительно протекающая эрозия, трудно поддающаяся лечению, должна рассматриваться как предраковое состояние.

**Симптомы и течение.** Гнойные серозные выделения, иногда с примесью крови; при наличии трихомонадного заболевания выделения пенистые, при заболевании гонорройной этиологии — зеленые.

Кровоточивость эрозии (после половых сношений, внутренних исследований) вызывает подозрение на рак.

Простая эрозия при соответствующем лечении эпителизируется в течение 2—3 месяцев.

**Распознавание.** Обязательное исследование зеркалами для установления этиологии эрозии. При подозрении на рак необходимо произвести биопсию и гистологическое исследование.

**Лечение.** При установлении заболевания вышерасположенных участков полового тракта (эндоцервицит, аднексит) необходимо провести соответствующее лечение этих заболеваний. Тампоны с сульфаниламидной или пенициллиновой мазью. Аутогемотерапия в шейку матки: из локтевой вены берут 5 мл собственной крови больной и двумя-тремя уколами вокруг эрозии вводят в шейку матки. Инъекции производятся через день в количестве 8—10 сеансов.

Хорошие результаты дает совместное введение собственной крови больной с пенициллином. Для этого пенициллин в количестве 200 000—300 000 единиц разводят в 1 мл физиологического раствора.

Затем в тот же шприц набирают 3—4 мл крови больной и производят инъекцию вокруг эрозии, как описано выше. При длительно протекающей эрозии применяют электрокоагуляцию. Однако прежде чем приступить к электрокоагуляции, надо исключить раковое заболевание шейки путем биопсии и гистологического исследования. С 4—5-го дня после электрокоагуляции проводят курс аутогемотерапии в шейку матки. Инъекции производятся через день в количестве 5—0.

В редких случаях при очень обширных эрозиях, трудно поддающихся лечению (после того как был исключен рак), производят ампутацию шейки матки. ■

## ГЛАВА IX

### БОЛЕЗНИ УХА, НОСА И ГОРЛА

**АБСЦЕСС. НАРЫВ ЗАГЛОТОЧНЫЙ (ABSCESSUS RETRO-PHARYNGEALIS).** Нагноение лимфатических узлов, расположенных в заглоточном пространстве. Наблюдается в раннем возрасте (до 2 лет), возникает чаще после ангины, воспалительных инфекционных заболеваний носа и носоглотки (острый насморк).

**Симптомы и течение.** Резко повышенная температура, затрудненное глотание, затрудненное носовое дыхание, носовой оттенок голоса, который становится глухим, инспираторная одышка, сопровождающаяся влажными хрипами и клокотанием в горле. Вследствие резких болей при глотании дети отказываются от еды. Характерно вынужденное положение головы — она отклонена кзади и в оольную сторону. Довольно часто наблюдается воспалительная инфильтрация позади угла нижней челюсти. На задней стенке глотки или носоглотки — шарообразное выпячивание флюктуирующей опухоли (зыбление).

**Лечение.** Возможно раннее вскрытие нарыва с необходимыми предосторожностями во избежание затекания гноя в гортань — нагибание головы кпереди и книзу немедленно после вскрытия нарыва. Пенициллинотерапия как в стадии инфильтрации, так и при нагноении.

**АБСЦЕСС ЗАГЛОТОЧНЫЙ БОКОВОЙ (ABSCESSUS LATEROPHARYNGEALIS).** Располагается на боковой стенке глотки — в окологлоточном пространстве. Чаще наблюдается у взрослых. Возникает в результате травмы слизистой оболочки глотки или инфицирования клетчатки ее боковой части. Такие абсцессы могут быть также ушного происхождения; в этих случаях при острых процессах и обострениях хронических процессов в височной кости гной проникает из сосцевидного отростка.

**Симптомы и течение.** Повышенная температура, тяжелое общее состояние, иногда ознобы, сильная боль при глотании, реже затрудненное дыхание. В отличие от заглоточного абсцесса отмечается затрудненное раскрытие рта. Боковая стенка глотки гиперемирована и отечна, миндалина, почти не вовлеченная в процесс, выпячивается кпереди.

**Лечение.** Вначале лед на шею, глотание льда кусочками, неспецифическая протеинотерапия. При отсутствии успеха от этих мероприятий — горячие компрессы на шею, горячие полоскания, паровые ингаляции. При намечающейся флюктуации — вскрытие абсцесса. Пенициллинотерапия как в стадии инфильтрации, так и при нагноении.

**АБСЦЕСС НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ** см. *Гематома носовой перегородки*.

**АБСЦЕСС ОКОЛОМИНДАЛИКОВЫЙ (ПЕРИТОНЗИЛЛЯРНЫЙ) (ABSCESSUS PERITONSILLARIS)**. Возникает как осложнение при хроническом воспалении миндалин, чаще после острых ангин. Инфекция проникает через миндаликовые щели (лакуны) в околоминдаликовую клетчатку и вызывает ее воспаление с последующим образованием нарыва.

**Симптомы и течение**. Резкая боль при глотании, отдающая в ухо. Температура высокая (38—40°). Соответствующая половина мягкого неба гиперемирована и отечна, язычок смещается в противоположную сторону. Лимфатические железы (шейные и подчелюстные) часто увеличены и болезненны. Больной с трудом раскрывает рот, голос становится гнусавым, принятие пищи затруднено или делается невозможным. Жидкая пища часто попадает в нос.

**Лечение** см. также *Лечение ангин*. Для ускорения созревания нарыва назначают тепло во всех видах: согревающие компрессы пащею, паровые вдыхания, частые полоскания слабо дезинфицирующими теплыми растворами (борная кислота, риванол, марганцовокислый калий, перекись водорода). При сильных болях — аспирин или пирамидон с кофеином; при бессоннице люминал. Пенициллин по 20 000—50 000 единиц внутримышечно через 3 часа в течение 2—3 дней. При намереющемся зыблении — вскрытие нарыва в месте наибольшего выпячивания через переднюю небную дужку скальпелем, обернутым липким пластырем, так, чтобы самый конец его на 0,5 см оставался свободным. Сначала делают небольшой надрез, а затем рану расширяют тупым путем (корнцангом, желобоватым зондом или другим инструментом). Если определить размягчение не удастся, разрез производят на середине линии, соединяющей язычок и последний коренной зуб, на глубину 1—1,5 см. Созревший нарыв можно вскрыть и тупым путем через надминдаликовую ямку или лакуну, прорвав капсулу миндалики изогнутым зондом, специальным инструментом Шнейдера или изогнутым корнцангом.

**АДЕНОИДЫ (VEGETATIONES ADENOIDES). ГИПЕРТРОФИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ**. Часто возникают после перенесенных инфекционных болезней (корь, скарлатина, дифтерия, грипп и т. д.); наблюдаются чаще в возрасте от 3 до 8—10 лет.

**Симптомы и течение**. Закладывание носа и постоянный насморк, не поддающийся обычному терапевтическому воздействию. Больные спят с открытым ртом, храпят во время сна и днем в большинстве случаев также держат рот полуоткрытым. Нередко они жалуются на головную боль и невозможность сосредоточить внимание на умственной работе (часто отстают в учебе). Аденоиды являются источником часто повторяющихся острых воспалений носоглотки вследствие наличия в их бухтах и складках обильной бактериальной флоры. Нередко процесс переходит на евстахиеву трубу и вызывает воспаление среднего уха. В результате нарушенной вентиляции евстахиевой трубы и среднего уха часто отмечается значительное понижение слуха.

**Распознавание**. При помощи задней риноскопии и путем ощупывания носоглотки пальцем.

**Лечение**. Оперативное удаление аденоидов. При противопоказаниях к операции — рентгенотерапия.

**АНГИНЫ ИНФЕКЦИОННЫЕ (ANGINAE INFECTIOSAE)**. Под ангиной принято понимать различные острые заболевания слизистой и лимфаденоидной ткани зева и глотки. Наиболее часто наблюдается поражение небных миндалин, реже третьей (расположена в носоглотке) и четвертой (расположена у корня языка) миндалины.

**Этиология и патогенез**. Возбудители — различные микробы, чаще стрептококки, реже диплококки, пневмококки, веретенообразная палочка совместно со спирохетами, стафилококки и др. В возникновении, течении и исходе заболевания главное значение имеет состояние защитных сил организма. Ангина может возникнуть от занесения инфекции извне или вследствие повышения болезнетворности микробов, постоянно находящихся в лакунах и складках миндалин, чему способствует ослабление организма под влиянием переохлаждения и других неблагоприятных внешних условий. Заболеваемость ангиной возрастает обычно весной и осенью в связи с температурными колебаниями. Очаговости заболевания (семейные ангины) способствует капельный способ передачи инфекции и однородность бытовых условий.

В зависимости от характера, тяжести и места развития воспаления, чаще встречается три вида ангин: катарральная (в воспаление вовлечена главным образом слизистая оболочка зева), лакунарная (воспаление сосредоточено преимущественно в лакунах миндалин) и фолликулярная (поражается паренхима миндалин — фолликулы). Наблюдаются и сочетанные формы, когда все составные части миндалин вовлекаются в процесс одновременно.

В зависимости от вида возбудителя и реакции организма, ангина может быть в одних случаях как бы местным очаговым заболеванием с более или менее выраженными, общими явлениями, в других — служить исходным пунктом тяжелой общей болезни (сепсис, заболевание суставов, сердца, почек и т. п.) и в третьих — быть одним из признаков общих заболеваний самого разнообразного происхождения.

**АНГИНА КАТАРРАЛЬНАЯ (ANGINA CATARRHALIS ACUTA)**.

**Симптомы и течение**. Вначале чувство сухости, саднения в горле, затем боли при глотании, иногда отдающие в ухо, усиленное слюноотделение и потребность часто глотать. Общие признаки: разбитость, головная боль, боли в суставах и во всем теле, познабливание или озноб. Температура повышена, а у маленьких детей может достигать высоких цифр и сопровождаться рвотой. Миндалины гиперемированы, несколько припухшие, покрыты слизью; в более тяжелых случаях точечные кровоизлияния в их слизистой. Ближайшие к пораженной миндалине (регионарные) шейные лимфатические узлы обычно увеличены, болезненны.

**АНГИНА ЛАКУНАРНАЯ (ANGINA LACUNARIS)**. Инфекционное заболевание, нередко встречающееся в виде семейных и больничных эпидемий. Обычно протекает при более резко выраженных

общих явлениях, чем катарральная ангина. Начинается внезапно — высокой температурой до 40°. У детей часто сопровождается бредом, общей разбитостью, головной болью, болью при глотании. На покрасневшей и припухшей слизистой миндалин в устьях лакун образуются выступающие из глубины щелей желтовато-белого цвета налеты в виде пробок, выполняющие щели (лакуны). Налеты состоят из серозно-фибринозного выпота с примесью эпителия, лейкоцитов и микроорганизмов (чаще стрептококков). Сами миндалины обычно увеличиваются в объеме. Налеты в виде полос могут постепенно распространяться и на возвышенные участки миндалин, но в отличие от дифтерии никогда не переходят за их пределы. Они легко снимаются ваткой, нагнутой на зонд. Регионарные (близлежащие) лимфатические шейные узлы увеличены, болезненны. Температура держится обычно 3—4 дня, после чего постепенно наступает выздоровление.

**АНГИНА ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ (ANGINA FOLLICULARIS).** Протекает самостоятельно или присоединяется к лакунарной ангине. Болезнь часто начинается внезапным ознобом и общим недомоганием, головной болью, болью при глотании, в конечностях, спине; температура повышается до 40° и больше. На покрасневшей поверхности обеих припухших миндалин появляется большое количество круглых, слегка возвышающихся желтовато-белых островков — налетов величиной с булавочную головку (нагноившиеся, фолликулы миндалин), которые делают поверхность миндалин похожей на звездное небо. От припухания слизистой зева голос нередко приобретает гнусавый оттенок. Близжайшие лимфатические шейные узлы увеличены, болезненны. Болезнь течет бурно и заканчивается обычно в течение недели полным выздоровлением или переходит в хронический тонзиллит. Ангины нередко сопровождаются осложнениями местного (околоминдаликовый нарыв, воспаление среднего уха) и общего (сепсис, эндокардит, пиемия, менингит, ревматизм, заболевание почек) характера.

**АНГИНА ЛЮДОВИКА (ANGINA LUDOVICI).** Острое флегмонозное воспаление клетчатки дна полости рта. Начале: ощущение неловкости и напряжение в подбородочной и подчелюстной области, боли при разговоре, жевании и глотании, общая разбитость, высокая септическая температура, отсутствие аппетита, бессонница. Прощупывается плотный, как доска, инфильтрат, который постепенно выполняет все пространство подчелюстной, а иногда и подбородочной области и может спускаться вниз по боковой и средней части шеи. Кожа над инфильтратом красная и отечная. Слизистая дна ротовой полости резко отечна. Раскрытие рта ограничено, болезненно, речь невнятна. В более тяжелых случаях, вследствие общего отравления (токсинами) и сдавления инфильтратом больших шейных сосудов и дыхательного горла, появляется синюха, одышка, иногда асфиксия.

**АНГИНА ЯЗВЕННО-ПЛЕНЧАТАЯ (ANGINA ULCERO-MEMBRANACEA).** Проявляется в виде желтовато-плечатых некротических налетов, расположенных на миндалинах и мягком небе. Налеты имеют иногда наклонность распространяться и на другие участки слизистой глотки, рта и гортани (картина, напоминающая дифтерию).

Налеты легко снимаются, оставляя после себя поверхностные язвы с неровными, подрытыми краями, склонные углубляться. Язвенный распад сопровождается дурным запахом изо рта. Регионарные шейные лимфатические узлы, как и глотание, мало болезненны. Температура субфебрильная, чаще нормальная. Заболевание продолжается около недели, но иногда при отсутствии лечения может тянуться неделями. В этих случаях изъязвление принимает ползучий характер, а в процесс разрушения может вовлекаться не только слизистая оболочка, но иногда и подлежащие ткани, вследствие чего при переходе процесса на надкостницу наблюдается некроз и прободение твердого неба; разрушение десен и выпадение зубов. Поверхностные язвы обычно заживают без образования дефектов.

**Лечение.** Постельное содержание, покой, обильное питье, жидкая, теплая, питательная пища, витамины. Следить за состоянием сердца, кишечника, почек (исследовать кровь и мочу). Полоскание зева слабым раствором вяжущих (шалфей, ромашка) и обеззараживающих средств: борная кислота 1/а или 1 чайная ложка на стакан воды, марганцовокислый калий (1 : 2 000), 3% раствор перекиси водорода и др. Согревающий компресс на шею, лучше спиртовой (1/3 спирта на 2/3 воды); бинтовать непременно через голову. Компресс менять через 3—4 часа с двухчасовыми перерывами. Внутрь — сульфаниламидные препараты (стрептоцид, сульфадiazин, норсульфазол, сульфазол), в зависимости от возраста от 0,1 до 1, и на прием через каждые 4 часа. При септических и других осложнениях — сульфаниламидные препараты, пенициллин внутримышечно 25 000—30 000 единиц и больше, в зависимости от тяжести процесса, через каждые 3—4 часа в течение 2—3 суток. Пенициллин или эритролин в таблетках.

При малейшем подозрении на дифтерию — немедленное введение противодифтерийной сыворотки даже в случае отрицательных результатов бактериологического исследования.

При язвенно-плечатой ангине — смазывание язв миндалин 1% раствором Люголя, 3% раствором хромовой кислоты; припудривание их новарсенолом, полоскание 2% раствором бертолетовой соли; пенициллин.

При ангине Людовика — хирургическое лечение, пенициллин.

**ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА ОСТРОЕ И ХРОНИЧЕСКОЕ.** Острое воспаление часто возникает в течении острого насморка, гриппа, кори, скарлатины и других инфекционных заболеваний.

**Симптомы и течение.** В легких случаях болезнь протекает иногда незаметно и проходит без всякого лечения. В более выраженных случаях больные жалуются на чувство давления и напряжения в области пораженной пазухи и одновременно на односторонний насморк, временами более обильное или даже гнойное отделяемое из одной половины носа, головную боль, в острых случаях — на боль при давлении в области соответствующей пазухи (лобной, гайморовой). В более тяжелых случаях присоединяются невралгические боли, локализующиеся часто в области лба, виска, скуловой кости, корня носа, и зубная боль. Температура обычно повышена. Нередко при заболеваниях гайморовой полости отмечает-

ся воспалительная припухлость щеки, а при заболевании лобной пазухи — припухлость области лба с отеком верхнего века, светобоязнь и слезотечение. Заболевание клеток решетчатого лабиринта чаще протекает в комбинации с заболеваниями лобной или гайморовых полостей.

При хроническом воспалении все субъективные симптомы выражены значительно слабее. Жалобы больных сводятся к одностороннему, часто гнойному хроническому насморку, иногда головной боли, быстрой утомляемости при умственной работе.

Очень часто на больной стороне отсутствует обоняние. При передней риноскопии обычно отмечают гиперемию и отечность слизистой оболочки среднего носового хода, избыток слизистого отделяемого в нем и иногда полоску гноя в среднем или верхнем носовом ходе. Часто можно еще наблюдать грануляции и полипы в области среднего носового хода.

**Р а с п о з н а в а н и е .** Для окончательного диагноза и разграничения поражений гайморовой, лобной, основной пазух и клеток решетчатого лабиринта требуется ряд дополнительных исследований, производимых врачом-специалистом: просвечивание пазух (диафаноскопия), рентгенография, пробный прокол и промывание гайморовой полости.

**Л е ч е н и е .** В острых случаях воспалений придаточных пазух носа с повышенной температурой больные нуждаются в стационарном лечении, в крайнем случае в постельном содержании. Обычно назначают жаропонижающие (аспирин 0,5, кофеин 0,1), по одному порошку 2—3 раза в день, а для уменьшения набухлости слизистой в области выводных отверстий придаточных пазух и облегчения оттока отделяемого — смазывания 10% кокаином среднего носового хода или впускание кокаиновых капель с адреналином или эфедрином.

Rp. Cocaini hydrochlorici 0,2  
Sol. Adrenalinii 1 : 1 000,0 gtt. X  
Sol. Acidi borici 4% 10,0  
MDS. По 10 капель 3—4 раза в день ♦

или, что лучше:

Rp. Cocaini hydrochlorici  
Ephedrinii hydrochlorici aaT 0,2  
Sol. Acidi borici 4% 10,0  
MDS. По 10 капель 3—4 раза в день

При впускании капель голова должна быть достаточно запрокинута и слегка повернута в большую сторону с тем, чтобы капли попали в средний носовой ход. Суженное, вследствие набухания слизистой, выходное отверстие придаточной пазухи расширяется, и в некоторых случаях можно наблюдать непосредственное вытекание гноя из среднего носового хода.

Весьма содействует излечению острого воспаления придаточных пазух назначение синего света, освещение лампой соллюкс, УВЧ терапия и в особенности диатермия: 12—15 сеансов прогревания пазух в течение 10—15 минут ежедневно дают хороший результат даже

в тяжелых случаях после инфекционных (грипп и др.) воспалений придаточных пазух.

В тяжелых случаях, сопровождающихся общей интоксикацией, резкими головными болями и обильным отделяемым из носа, в течение 3—5 дней применяют внутримышечно пенициллин. В затянувшихся случаях, с обильным выделением гноя, а также при неблагоприятных анатомических соотношениях прибегают к небольшим оперативным вмешательствам, которые производит врач-специалист (частичное удаление средней носовой раковины, повторные проколы гайморовой пазухи с последующим промыванием пенициллином).

Хронические воспаления придаточных пазух вначале лечат так же, как и острые. В случаях неблагоприятных анатомических соотношений для стока отделяемого производят частичное удаление средней раковины и резекцию искривленной носовой перегородки. В случае неуспеха такого лечения прибегают к хирургическому вскрытию и дренированию через нос пораженной пазухи. Операцию должен производить врач-специалист.

**ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УХА ОСТРОЕ (OTITIS MEDIA ACUTA).** Возникает в случае попадания инфекции в барабанную полость при насморке, аденоидах, усиленном сморкании или промывании носа и особенно при острых инфекционных заболеваниях (грипп, корь, скарлатина). Наиболее частые возбудители — стрептококки и стафилококки.

**С им п т о м ы и т е ч е н и е .** Тяжесть течения острых отитов зависит от общей реактивности организма, регулируемой деятельностью центральной нервной системы. Жалобы на резкие боли в ухе, понижение слуха, шум в ушах, повышение температуры (у детей до 40°). При осмотре барабанной перепонки — гиперемия, сглаживание опознавательных пунктов, затем выпячивание перепонки. В дальнейшем возможно прободение ее и гноетечение из уха. Температура обычно после этого падает, все субъективные явления проходят. Обратное развитие болезни и выздоровление возможны в любой ее стадии. Наиболее частые осложнения — мастоидиты, воспаления внутреннего уха (лабиринтит), реже внутричерепные осложнения (менингит, нарыв мозга) (см. гл. III, *Болезни нервной системы*) и сепсис (см. *Сепсис отогенный*).

**Л е ч е н и е .** До прободения — вливание в ухо 3—5% раствора карболово-глицериновых капель в теплом виде (по 5—8 капель), аспирин (по 0,5 три раза в день), согревающий компресс на область уха и сосцевидного отростка. При очень высокой температуре назначают сульфаниламиды по 2,0—3,0 в день, пенициллин по 200 000—400 000 единиц в Ютки равными дозами-через 3 часа (внутримышечный). При выпячивании барабанной перепонки, резких болях и высокой температуре делают парацентез (разрез барабанной перепонки). С появлением гнойного отделяемого после разреза или самопроизвольного прободения перепонки карболово-глицериновые капли отменяют и назначают сухую очистку слухового прохода ватой, намотанной на зонд, с последующим введением теплых капель перекиси водорода или 0,5% сернокислого цинка (Sol. Zinci sulfurici 0,5%), затем вторично высушивают слуховой проход и осторожно вводят туда марлевый тампончик. Такие процедуры, в зависимости

от интенсивности гноетечения, повторяют 3—5 и больше раз в день.

**ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УХА ХРОНИЧЕСКОЕ ГНОЙНОЕ** (OTITIS MEDIA CHRONICA). Острое гнойное воспаление среднего уха переходит в хроническое при небрежном лечении, наличии хронических воспалительных процессов в носу и носоглотке (гнойные воспаления пазух, аденоиды и т. д.), понижении общей сопротивляемости организма.

**Симптомы и течение.** Стойкое прободение барабанной перепонки, постоянное или периодически повторяющееся гноетечение из уха, понижение слуха.

**Лечение.** При преимущественном поражении слизистой оболочки среднего уха лечение то же, что и при остром гнойном воспалении. При поражении кости (кариес, холестеатома) консервативное лечение и затем удаление полипов, прижигания грануляций 10—30% раствором ляписа, промывания надбарабанного пространства. В случае неуспеха такого лечения — радикальная операция.

Обязательно лечение воспалительных заболеваний носа и носоглотки, как и при всех воспалительных заболеваниях уха.

**ГАЙМОРИТ** см. *Воспаление придаточных пазух носа.*

**ГЕМАТОМА (КРОВАЯ ОПУХОЛЬ) НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ.** Наружные повреждения носа часто ведут к подслизистой гематоме носовой перегородки, которая под влиянием вторичной инфекции переходит в нарыв.

**Симптомы и течение.** При риноскопии или даже при поднятии кончика носа пальцем видна выпирающая из носового отверстия мешковидная яркокрасная опухоль, легко сжимаемая при дотрагивании пуговчатым зондом. Температура обычно повышена, нос заложен, головная боль.

**Лечение.** Операция, которую должен производить врач-специалист.

**ГИПЕРТРОФИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ** см. *Аденоиды.*

**ГИПЕРТРОФИЯ НЕБНЫХ МИНДАЛИН.** Встречается обычно в детском возрасте как реакция после острых инфекционных заболеваний.

**Симптомы и течение.** Миндалины резко увеличены, выступают из-за небных дужек, иногда соприкасаются одна с другой и закрывают вход в глотку. Воспалительные явления у детей обычно отсутствуют.

**Лечение.** В случаях, когда гипертрофия миндалин сопровождается нарушением дыхания или голосового звучания, прибегают к оперативному вмешательству, которое производит врач-специалист.

**ГЛУХОНЕМОТА.** Причиной немоты является глухота врожденная, вследствие недоразвития периферических нервных окончаний во внутреннем ухе, или приобретенная в раннем детстве в результате той или другой инфекции (цереброспинальный менингит, тифы, скарлатина, корь, свинка, дифтерия, сифилис и т. д.).

**Симптомы.** Изменения со стороны барабанной перепонки и среднего уха встречаются редко (они наблюдаются при глухоноте приобретенной). У части глухонемых имеется полное выпадение слуховой функции (абсолютная глухота), у другой части остатки

в»

слуха сохранены. Наличие более или менее значительных остатков слуха дает основание надеяться на улучшение функции слуховых анализаторов и облегчает процесс обучения глухонемого.

**Лечение.** В большинстве случаев глухота, обусловленная гибелью нервных окончаний внутреннего уха, не поддается лечению. Наоборот, в случаях глухоты, связанной с заболеванием среднего уха, следует применять энергичное лечение. Остатки слуха у глухонемых развивают при помощи специальной акустической аппаратуры.

Глухонемые обучаются в особых школах. Отсутствующие слуховые восприятия заменяются зрительными (обучение чтению с губ). В этих же школах их обучают устной речи, что дает весьма положительные результаты: многие глухонемые кончают средние и высшие учебные заведения.

**ДИФТЕРИЯ ГОРТАНИ** см. *Круп гортанный истинный.*

**ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ГОРТАНИ И БРОНХОВ.** В гортань, трахею и бронхи при внезапном вдохе, во время крика, разговора, смеха, реже во время еды могут попасть различные инородные тела из полости рта.

**Симптомы и течение.** Периодические признаки судорожного кашля и удушья. При застревании инородного тела между голосовыми связками обычно происходит внезапная потеря голоса. Подвижные инородные тела в дыхательном горле ударяясь при дыхании о нижнюю поверхность голосовых связок, производят характерный хлопающий шум. Они легко выбрасываются из дыхательного горла при трахеоскопии и трахеотомии. Плотное засевшее инородное тело в одном из бронхов, чаще в правом, вызывает в соответствующей половине легкого ослабление дыхательного шума, притупление перкуторного звука и уменьшение размаха колебаний грудной клетки. Легкие и подвижные инородные тела могут выбрасываться рефлексорным кашлем. Продолжительное пребывание инородного тела ведет к воспалению легких, гнойнику или гангрене легкого.

**Лечение.** Удаление инородных тел путем бронхоскопии, которое производит врач-специалист. В случаях резкого нарушения дыхания — трахеотомия и последующее удаление инородного тела.

**ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НОСА.** Чаще встречаются у детей, которые вносят их в полость носа во время игры. Нередко длительное пребывание инородных тел приводит к откладыванию вокруг них известковых солей и образованию носовых камней (ринолитов).

**Симптомы и течение.** Инородные тела обычно помещаются в нижнем носовом ходе. Гладкие инородные тела вызывают в одних случаях только нарушение проходимости носа, в других — раздражение слизистой, обильное, нередко гнойное с резким запахом отделяемое из одной половины носа, которое у детей является характерным признаком присутствия инородного тела.

**Лечение.** Удаление инородных тел производится под местной анестезией, а у беспокойных детей — под общим наркозом. Слизистую носа смазывают 3% кокаином или 1% раствором дикаина с адреналином. Тупой крючок проводят за инородное тело под конт-

ролем глаза, а затем, поворачивая его движением к себе, извлекают инородное тело.

**ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА УХА.** -Самые разнообразные предметы могут попадать в наружный слуховой проход и застревать в нем иногда на долгое время, не вызывая никаких признаков. В других случаях появляется рефлекторный кашель, понижение слуха. Неумелая попытка удаления инородного тела приводит к воспалению слухового прохода, а иногда к прободению барабанной перепонки и воспалению среднего уха.

**Лечение.** Инородные тела удаляют, промывая слуховой проход теплой водой. Живые инородные тела (насекомые) предварительно умерщвляют, вливая несколько теплых капель 5% раствора карболового глицерина, вазелинового или камфорного масла или хлороформной воды. Если извлечь инородные тела промыванием не удается, врач удаляет их тупым или острым крючком под контролем зрения с помощью рефлектора через ушную воронку. Удалять инородные тела пинцетом нельзя. Инородные тела, склонные к набуханию, перед извлечением обезвоживают вливанием в слуховой проход 96° спирта (по 10 капель 4—5 раз в день в течение 1—2 дней).

**ИСКРИВЛЕНИЕ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ.** У взрослых перегородка носа редко бывает прямой, расположенной в срединной плоскости, обычно она отклоняется в ту или другую сторону от вертикальной плоскости. Эти искривления иногда достигают такой степени, что перегородка соприкасается с боковой стенкой носа. На перегородке наблюдаются заостренные шипы или гребни.

В возникновении искривлений перегородки носа известную роль играет травма. Основным симптомом искривления носовой перегородки является затруднение дыхания через одну или через обе половины носа.

**Лечение.** Операция, которую производит врач-специалист.

**КРОВОТЕЧЕНИЕ НОСОВОЕ (EPISTAXIS).** Местные причины: травма носа, ковыряние в носу, удаление крепко приставших корочек, кровоточащие опухоли и язвы в носу. Общие причины: инфекционные заболевания, болезни кроветворных органов и болезни сердца, печени и почек, гипертоническая болезнь, артериосклероз. Самый частый (до 90%) участок кровотечения — передне-нижняя часть носовой перегородки, примерно на 1 см отступа от входа в нос.

**Лечение.** Наиболее простой способ — тампонада носа спереди куском ваты или марли, смоченной перекисью водорода, приподнятое положение головы, освобождение от стесняющей одежды, холодные компрессы на нос и затылок. При повторных кровотечениях — анестезия, а затем прижигание кровоточащего участка хромовой или трихлоруксусной кислотой. В тяжелых случаях передняя и задняя тампонада и назначение средств, повышающих свертываемость крови (10% хлористый кальций в вену), аутогемо-терапия по 5—10 мл, а также переливание крови по 150—200 мл повторно. Лечение основного заболевания.

**КРУП ГОРТАННЫЙ ИСТИННЫЙ. ДИФТЕРИЯ ГОРТАНИ (LARINGITIS SCOUPOSA).** Дифтерия гортани и дыхательного горла может быть первичной и вторичной.

**Симптомы и течение.** Обычно тяжелое общее состояние с высокой температурой, хриплый голос, беззвучный кашель, нарастающая одышка, удушье, нарастающее ухудшение общего состояния, слабость сердечной деятельности вследствие общей интоксикации. При ларингоскопии — сероватые пленки, заполняющие просвет гортани и подвязочного пространства.

**Лечение.** Введение антитоксической противодифтерийной сыворотки в количестве 15 000—20 000 единиц через каждые 5—6 часов. Интубация или трахеотомия при резко выраженном затрудненном дыхании.

**КРУП ГОРТАННЫЙ ЛОЖНЫЙ, ПОДСВЯЗОЧНОЕ ОСТРОВ ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ (LARYNGITIS SUBCHORDALIS).** В основе заболевания лежит предрасположение, экссудативный диатез. **Симптомы и течение.** Внезапное (обычно ночью) появление лающего кашля, затрудненное дыхание, страх. Голос мало изменен. Характерно внезапное появление и быстрое окончание припадка.

**Лечение.** Постельный режим, обильное теплое питье, аспирин по 0,3 два-три раза в день, отвлекающие (банки, горчичники), горячие компрессы на шею.

**ЛАВИРИНТИТ.** Лабиринтит является одним из тяжелых осложнений острого и хронического гнойного воспаления среднего уха. Это заболевание нередко ведет к гибели окончаний кохлеарного и вестибулярного нервов во внутреннем ухе.

**Симптомы.** Головокружение, тошнота, рвота, расстройства равновесия, нистагм, потеря слуха. Температура обычно нормальная. Значительное повышение температуры свидетельствует о переходе процесса на мозговые оболочки.

**Лечение.** Консервативное (абсолютный покой, постельный режим, сульфаниламиды, пенициллин, бром, валериана) или хирургическое в условиях врачебного стационара, в зависимости от характера заболевания и состояния среднего уха.

**ЛАРИНГИТ ОСТРЫЙ (LARYNGITIS ACUTA). ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ.** Наступает при гриппе, кори, скарлатине, брюшном тифе вследствие перенапряжения голоса, а также в результате простуды.

**Симптомы и течение.** В зависимости от выраженности воспалительного процесса, голос становится хриплым, появляется кашель, сухость, саднение в горле, иногда головная боль и незначительное повышение температуры. При ларингоскопии отмечается разлитая гиперемия слизистой гортани, набухлость, краснота голосовых связок и комочки слизи на них.

**Лечение.** Молчание, тепло на шею (согревающий компресс, горячие припарки), диатермия, паровые щелочные ингаляции несколько раз в день. Аспирин по 0,5 два раза в день, наркотики или отхаркивающие микстуры.

**ЛАРИНГИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (LARYNGITIS CHRONICA).** Развивается в результате часто повторяющегося острого воспаления гортани. Возникает также у привычных алкоголиков, курильщиков и у лиц с профессиональным перенапряжением голоса (певцы, педагоги и т. д.).



**Симптомы и течение.** Жалобы на хрипоту, быструю утомляемость голоса, ощущение першения и царапания в горле, нередко постоянное откашливание. При осмотре зеркалом — слизистая оболочка гортани серо-красного цвета, местами утолщена, особенно по краям истинных голосовых связок и в межчерпаловидном пространстве. Слизистая ложных голосовых связок бывает отечной, припухшей, нередко покрывает полностью или частично истинные голосовые связки, нарушая фонацию. Часто развиваются ограниченные утолщения эпителия в межчерпаловидном пространстве, на внутренней поверхности черпаловидных хрящей и на задних отделах истинных голосовых связок, которые носят название пахидермии.

В других случаях на голосовых связках друг против друга образуются маленькие утолщения слизистой, так называемые «узелки певцов», вызывающие хрипоту. При атрофии слизистой образуются корки, сухость в горле, что вызывает мучительный кашель. Течение длительное с периодическим ухудшением состояния.

**Лечение.** Устранить причины, поддерживающие заболевание: прекратить курение, не злоупотреблять алкоголем, не перенапрягать голоса. Периодическое смазывание слизистой оболочки 1—2% раствором ляписа или иод-глицерина, щелочные (2% раствор соды) и масляные (ментоловые) ингаляции, курортное лечение.

**Мастоидит острый (MASTOIDITIS ACUTA). ВОСПАЛЕНИЕ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА.** При остром гнойном воспалении среднего уха процесс нередко переходит на клетки сосцевидного отростка, расплавляя их перегородки и образуя полость, заполненную гноем или грануляциями. Костные разрушения могут идти как по направлению к поверхности коркового слоя сосцевидного отростка, так и в сторону средней и задней черепной ямки.

**Симптомы и течение.** Повышенная температура (от субфебрильной до 39—40°), боли в сосцевидном отростке, головная боль, бессонница, пульсирующий шум и боль в ухе. При разрушении наружной костной пластинки гной из сосцевидного отростка проникает под надкостницу и мягкие покровы, пропитывая их. В дальнейшем образуется поднадкостничный гнойник позади слухового прохода. При осмотре в слуховом проходе обнаруживается густой гной, выделяющийся через прободение барабанной перепонки, а также свисание его задне-верхней стенки. Осложнения: воспаления внутреннего уха, внутричерепные осложнения и сепсис.

Распознаванию помогает рентгенография. Необходимо исключить фурункулез слухового прохода, при котором слух не изменен.

**Лечение** то же, что и при острых гнойных воспалениях среднего уха с применением льда на сосцевидный отросток. Пенициллин. В случае неуспеха — операция в условиях врачебного стационара.

**МЕЛЬБЕРА БОЛЕЗНЬ.** **Симптомы.** Внезапные припадки: понижение слуха на одно ухо, шум в ушах, резкое головокружение, тошноты и рвоты. Продолжительность припадков от нескольких часов до 5—7 дней. Барабанные перепонки не изменены.

**Лечение.** Постельный режим, очистка кишечника, назначение бромидов и хинина (по 0,1—0,2 несколько раз в день), а также потогонных, мочегонных.

**НАСМОРК АТРОФИЧЕСКИЙ (RHINITIS ATROPHICA).** Болезнь заключается в атрофическом состоянии слизистой оболочки полости носа, которое сопровождается уменьшенным отделением секрета. Секрет становится вязким, имеет наклонность к засыханию и образованию корок.

**Симптомы и течение.** Жалобы на сухость в носу и глотке, тягостное чувство давления в области носа и головные боли, ослабление обоняния, закладывание носа (в результате обильного образования корок). При риноскопии полость носа, вследствие атрофии слизистой оболочки и носовых раковин, представляется очень широкой. Через хоаны нередко удается видеть носоглотку.

**Лечение.** Щелочные (2% раствор соды) и щелочно-масляные ингаляции, индифферентные мази, вазелиновое масло, 0,25—0,5% раствор иод-глицерина в виде капель или смазывания слизистой оболочки носа (ежедневно, через день).

Вр. Jodi puri 0,1  
Kalii jodati 0,5  
Glycerini 50,0  
MDS. Для смазывания носа

**НАСМОРК ВАЗОМОТОРНЫЙ (СОСУДОДВИГАТЕЛЬНЫЙ) или НЕВРОГЕННЫЙ РЕФЛЕКТОРНЫЙ.** Наблюдается большей частью у лиц с повышенной нервной чувствительностью.

**Симптомы и течение.** Насморк наступает приступами, сопровождаясь обильным водянистым выделением, чиханием, закладыванием носа, слезотечением, гиперемией конъюнктивы.

**Лечение.** Понижение нервной возбудимости путем осторожного закаливания организма (водолечение) и регуляции условий труда и быта. Железо, мышьяк, валериана, препараты брома и кальция. Ослабление чувствительности слизистой оболочки носа достигается впрыскиванием 1—2 мл 80° спирта с 1% раствором новокаина под слизистую оболочку нижних и средних носовых раковин. Рекомендуется также подкожное введение гистамина малыми, постепенно возрастающими дозами. Анатомические препятствия в носу (искривления, полипы, аденоиды), затрудняющие дыхание и поддерживающие вазомоторный насморк, устраняются хирургическим путем.

Вр. Sol. arsenicalis Fowleri 5,0 T-rae Ferri pomati 20,0  
M,DS. По 10—30 капель 3—4 раза в день

Вр. Natrii bromati  
Kalii bromati aa 3,0  
T-rae Valerianae 2,0  
Aq. destill. 200,0  
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Вр. Dimedrol 0,02 Sacchari 0,2  
MDS. По 1 порошку 2—3  
раза в день

**НАСМОРК ЗЛОВОННЫЙ (ОЗЕНА) (OZAENA).** Симптомы и течение. Болезнь характеризуется атрофией слизистой оболочки носа и костного скелета раковин, густыми, легко засыхающими в корки выделениями с резко зловонным запахом, часто понижением или полной потерей обоняния. Заболевание начинается в молодом возрасте и длится годами. При риноскопии полость носа представляется очень широкой. Изъязвлений в носу не бывает.

Лечение симптоматическое, направленное против имеющейся сухости и образования корок в носу; промывание носа щелочными растворами (сода, бура по половине чайной ложки на стакан кипяченой воды) и последующее смазывание иод-глицерином или ментоловым маслом.

Pr. 01. Mentholi 1% 10,0

DS. Капли для носа. По 5 капель 3 раза в день

Rp. Jodi puri 0,05 Kalii jodati 0,2

Glycerini 10,0 01. Menthae  
gtt. II MDS. Капли для носа

**НАСМОРК ОСТРЫЙ (RHINITIS ACUTA).** Вызывается инфекцией, особенно гриппом. Предрасполагающий момент — охлаждение.

Симптомы и течение. Начинается ощущением сухости в носу, чиханием, жжением и колотьем в горле и носоглотке. Затем наступает закладывание носа, проявляется обильное отделяемое, вначале прозрачное, затем мутное и слизисто-гнойное. Одновременно появляется ощущение тяжести в голове, головная боль и невралгические боли в области лица, изменение тембра голоса, конъюнктивит.

Лечение симптоматическое: устранение закладывания носа применением раствора кокаина с адреналином или ментола в виде капель в нос или мази; еще лучше действует солянощелочной эфедрин также в виде капель или мази.

Детям до 3 лет кокаин и ментол давать нельзя. Им вводят в нос по одной капле (несколько раз в день) раствора адреналина (1:10 000) или эфедрина (1—2%) после предварительной очистки входа в нос или масла сладкого миндаля (01. Amygdalarum dulcium) по 1—2 капли.

Rp. Cocaini hydrochlorici 0,1

Sol. Adrenalinum hydrochlorici (1 : 1 000) 0,3 Aq.  
destill. 10,0

MDS. Капли для носа. По 5 капель несколько раз в день

Rp. Cocaini hydrochlorici 0,1

Ephedrinum hydrochlorici 0,2 Sol. Acidi boricum 2%  
10,0 MDS. Капли для носа. По 5 капель 4—5 раз в день

Rp. Ephedrinum hydrochloricum 0,3  
Mentholi 0,1 Acidi boricum 0,5  
Lanolinum Vaselinum ad 6,0 MDS.  
Мазь

Профилактикой острых насморков является закаливание организма путем применения рациональных методов физической культуры.

**НАСМОРК ХРОНИЧЕСКИЙ (RHINITIS CHRONICA).** Хронический насморк наблюдается в двух формах: 1) в виде так называемого простого хронического насморка и 2) в виде гипертрофического насморка. Появляется в результате часто повторяющихся острых воспалений, инфекционных болезней, профессиональных вредностей, наличия аденоидов и т. п.

Симптомы и течение. Простой хронический насморк характеризуется разлитой гиперемией и равномерной припухлостью слизистой оболочки носа. Симптомы его те же, что и при остром насморке, но выражены менее резко. Затруднение носового дыхания дает себя больше чувствовать при лежании (на боку или на спине). Выделения из носа обыкновенно жидкие. При гипертрофическом насморке наблюдаются бугристые, дольчатые или крупнозернистые разрастания всей нижней носовой раковины, нижнего края или переднего и заднего ее концов. Заложенность носа более постоянная, не изменяется при перемене положения головы и тела; слизь имеет более густую консистенцию и отделяется с трудом.

Лечение. Предварительное устранение общих причин, поддерживающих хроническое течение. Из местных средств применяют: 1) вяжущие капли из 1—2% раствора протаргола или смазывание слизистой носа 1—3% раствором ляписа (через день в течение 2—3 недель); 2) прижигание хромовой, трихлоруксусной кислотой или гальванокаутером отдельных гипертрофических участков. Резко гипертрофированные части раковин удаляют оперативно.

**НЕВРА СЛУХОВОГО (УЛИТКОВОЙ ВЕТВИ) ВОСПАЛЕНИЕ, НЕВРИТЫ (NEURITIS N. COCHLEARIS).** Наступают в результате: 1) инфекционных болезней, перенесенных тифов, гриппа, цереброспинального менингита, кори, скарлатины и т. д.; 2) травм черепа; 3) общих заболеваний (артериосклероза, нефрита, диабета и т. д.); 4) отравления лекарственными веществами (хинином, салициловым натрием); 5) отравления ядами (мышьяком, свинцом, ртутью, фосфором и др.); 6) злоупотребления алкоголем и курением.

Симптомы и течение. Постепенное ухудшение слуха, иногда почти до полной глухоты. Частые жалобы на шум в ушах. При одновременном поражении вестибулярного нерва может наблюдаться головокружение.

Лечение. Устранение причин, вызвавших заболевание. Запрещение курения и употребления алкоголя; инъекции пилокарпина, препараты пода, стрихнина, мышьяка, фосфора, железа, кальция, брома и т. д.

**08ЕНА** см. *Насморк зловонный.*

**ОПУХОЛИ ГОРТАНИ.** Разделяются на доброкачественные и злокачественные. К доброкачественным относятся фибромы (гортанные полипы), папилломы, ангиомы и кисты.

**Симптомы и течение.** В большинстве случаев отмечается охриплость голоса и даже полная афония. При ларингоскопии обнаруживается опухоль округлой формы величиной от булавочной головки до лесного ореха, расположенная в передней или средней трети истинной голосовой связки, бледнорозового или красного цвета (фиброма). Папиллома представляет собой множественную опухоль, локализирующуюся не только на истинных голосовых связках, но и в других местах гортани и похожую на цветную капусту или петуший гребень. Ангиома имеет вид небольшой опухоли синевато-красного цвета, с неровной поверхностью, а киста — полусферической или несколько удлиненной гладкой опухоли.

**Лечение.** Оперативное.

**ОПУХОЛИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ГОРТАНИ** см. *Рак гортани.*

**ОПУХОЛИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОСА (РАК, САРКОМА).**

**Симптомы и течение.** Обычно одностороннее закладывание носа, выделения с запахом из этой половины и кровотечение. При дальнейшем росте опухоли — деформация лицевого скелета, невралгические боли. При риноскопии — часто бугристая, кровоточащая при исследовании зондом опухоль. Окончательная диагностика устанавливается гистологическим исследованием удаленного кусочка опухоли, производимым в больничных условиях врачом-специалистом.

**Лечение.** Хирургическое в сочетании с лучистой терапией.

**ОТИТ** см. *Воспаление среднего уха.*

**ОТОСКЛЕРОЗ (OTOSCLEROSIS).** Своеобразное заболевание преимущественно костной капсулы лабиринта, которое превращает плотную костную ткань в губчатую; вызывает окостенение ниши овального окна и неподвижность стремечка.

Причины заболевания до сих пор не выяснены. ^Болезнь чаще наблюдается у женщин и начинается в молодом возрасте.

**Симптомы и течение.** Постепенно нарастающее понижение слуха, достигающее почти до полной глухоты, сопровождающееся субъективным шумом в ушах. Барабанная перепонка сохранена и нормальна. Вначале поражается преимущественно звукопроводящий аппарат и нарушается восприятие низких звуков через воздух. Костная проводимость сохранена и даже усилена.

**Лечение.** Внутрь — йодистый калий, фосфор. Создание общих благоприятных условий труда, быта и отдыха. Лечение всех других заболеваний организма.

Rf. Sol. Kalii jodati 0,0—200,0

DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Rp. Calcii glycerophosphorici 0,5

D. t. d. N. 20 S. По 1 порошку 4 раза в день

...

**ПАРАЛИЧИ ГОРТАННЫХ МЫШЦ.** Расстройство двигательной функции гортани может быть как центрального, так и периферического происхождения. Причиной центральных параличей являются разнообразные процессы, расположенные в коре мозга, варо-лиевом мосту, продолговатом мозгу и в других отделах ствола мозга. Периферические параличи наступают в результате повреждения возвратного нерва, нередко сдавливаемого опухолями средостения, аневризмой аорты, раком пищевода, или вследствие неврита этого нерва алкогольного, сифилитического и ревматического происхождения.

**Симптомы** зависят от поражения тех или иных мышц гортани и степени этого поражения.

Жалобы больных сводятся к той или другой степени хрипоты или затруднения дыхания.

**Лечение** парезов и параличей должно быть направлено на устранение основной причины. Рекомендуется длительное молчание и электротерапия.

**ПЕРИХОНДРИТ ГОРТАННЫХ ХРЯЩЕЙ (PERICHONDRIITIS LARYNGIS).** Воспаление надхрящницы гортанных хрящей может быть первичным после травмы или вторичным при острых или хронических инфекционных, а также злокачественных новообразованиях.

**Симптомы и течение.** Боли при глотании и разговоре, повышение температуры. При ларингоскопии обнаруживают значительную инфильтрацию и отек надгортанника, черпаловидных хрящей и соседних участков слизистой. Наступающее затруднение дыхания при быстром развитии отека приводит к асфиксии. В других случаях возникают абсцессы с полным или частичным некрозом хряща и образование свищей.

Воспалительный процесс в результате рубцовых изменений ведет к хроническому стенозу гортани и невозможности удалить трахеотомическую трубку.

**Лечение.** В острых случаях — противовоспалительные мероприятия (покой, глотание льда, лед на шею). Пенициллин. При угрожающих симптомах и асфиксии — трахеотомия.

В случаях хронических рубцовых стенозов — оперативное восстановление просвета гортани в условиях врачебного стационара.

**ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОРТАНИ** могут быть нанесены как снаружи, так и изнутри. Наружные повреждения: ушибы, сдавления, резаные, колотые и огнестрельные раны; внутренние повреждения: ожоги, ссадины или другие повреждения инородными телами.

**Симптомы и течение.** Кровотечения (наружные и внутренние), афония (потеря голоса, боль в горле, выход воздуха из раны при проникающих ранениях), кашель с выделением пенистой кровянистой мокроты, подкожная эмфизема.

**Лечение.** Первая помощь: остановка кровотечения, устранение опасности удушья, при наличии асфиксии — трахеотомия. Для обеспечения покоя, устранения кашля и болевых ощущений — наркотики (подкожно кодеин, морфин, пантопон по 1 мл 1% раствора 2 раза в день),

**ПОВРЕЖДЕНИЯ НОСА И ЕГО ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ.**

Различают ушибы, повреждения мягких частей, простые и сложные переломы хрящевого и костного скелета. Большей частью повреждаются носовые кости. В результате травмы происходят искривления, вывихи или переломы носовой перегородки.

**Симптомы и течение.** Носовое кровотечение, боли, непроходимость носа (вследствие кровоизлияния и вторично наступающего отека мягких тканей в области повреждения). На месте перелома ощупыванием определяется смещение костей, треск и болезненность.

**Лечение.** Остановка кровотечения (см. *Кровотечение носовое*), вправление костных отломков и закрепление их в правильном положении путем асептической тампонады и наружной повязки. Образовавшуюся гематому носовой перегородки следует вскрыть или отсосать, чтобы предупредить образование нарыва.

**ПОВРЕЖДЕНИЕ УХА.** Повреждение барабанной перепонки может наблюдаться при ковырянии в ухе шпилькой, спичкой, при неумелых попытках удаления инородных тел и при резких колебаниях атмосферного давления (в случае разрыва снарядов, бомб и мин, быстрого подъема или спуска самолета, шлюзовании или вышлюзовании в кессоне).

Разрывы барабанной перепонки возможны при переломах черепа, ударе по голове или сдавлении черепа.

**Симптомы и течение.** Повреждения барабанной перепонки сопровождаются болью в момент травмы, кровоизлияниями в слуховой проход, шумом в ушах, понижением слуха, иногда головокружением. При осмотре барабанной перепонки определяется разрыв с резко гиперемизированными краями и наличием кровоизлияния в них. Главная опасность при разрывах заключается в возможности инфицирования барабанной полости и развития гнойного воспаления среднего уха.

**Лечение.** Всякое промывание уха, грубая очистка слухового прохода в первые дни после травмы запрещаются. Первая помощь заключается в наложении стерильной повязки в\*а ухо; в дальнейшем необходимо наблюдение специалиста.

Повреждения среднего и внутреннего уха являются чаще всего следствием огнестрельных ранений, в большинстве случаев комбинированных с повреждением черепной полости, крупных сосудов и других органов. Первая помощь подается по общим правилам хирургии: асептическая повязка на ухо, остановка кровотечения. Последующие наблюдение и лечение должны вестись врачом-специалистом.

**ПОЛИПЫ НОСА (POLYPOSIS NASI).** Образуются в результате хронического воспаления слизистой носа и его придаточных пазух.

**Симптомы и течение.** Полипы имеют серый, иногда желтовато-красный студенистый вид и гладкую поверхность. Часто вся носовая полость бывает заполнена мелкими полипами или один громадный полип заполняет всю полость вплоть до хоан включительно.

**Лечение.** Оперативное; производится врачом-специалистом

**ПОЛИПЫ УХА (POLIPUS AURIS).** Наблюдаются при хронических гнойных воспалениях среднего уха, сопровождающихся костоедой стенок среднего уха.

**Симптомы и течение.** Гноетечение из уха с примесью кровянистого отделяемого.

**Лечение.** Удаление полипной петлей или отсечение полипа другим инструментом у основания, которое производится врачом-специалистом. Остатки полипа и грануляции прижигаются 10—30% ляписом с последующей нейтрализацией (промывание физиологическим раствором). В дальнейшем лечение то же, что и при хроническом гнойном воспалении среднего уха.

**РАК ГОРТАНИ (CANCER LARYNGIS).** **Симптомы и течение.** Внезапно наступающая хрипота без предшествующих простудных и воспалительных заболеваний подозрительна в отношении рака. Развитие опухоли идет постепенно: появляется односторонняя незначительная гиперемия или инфильтрат, без резкой границы переходящий на окружающие ткани. В дальнейшем возникает плотная инфильтрация голосовой связки, которая становится неподвижной. Хрипота -к этому времени усиливается, наступает полная афония. С течением времени наступает изъязвление, резкий кашель и боль во время глотания. Лимфатические железы опухают и плотными узлами сдавливают гортань.

В подозрительных случаях биопсия облегчает диагностику. Профилактику см. гл. VI *Хирургические болезни. Рак.*

**Лечение.** Возможно ранняя операция удаления гортани, которая производится врачом-специалистом, или облучение ее рентгеновыми лучами и радием.

**РИНОСКЛЕРОМА** см. *Склерома гортани.*

**СЕПСИС ОТОГЕННЫЙ. СЕПСИС УШНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.**

При гнойных воспалениях среднего уха (острых и хронических) в воспалительный процесс может вовлекаться непосредственно прилежащая поперечная или сигмовидная пазуха твердой мозговой оболочки или инфекция по лимфатическим и венозным путям попадает в ту же пазуху, вызывая ее воспаление к образованию тромба (тромбофлебит). Инфицированный тромб в дальнейшем подвергается гнойному распаду, и частички его могут заноситься током крови в различные органы и ткани (легкие, подкожную клетчатку, суставы и другие органы).

**Симптомы и течение.** При тромбофлебите обычно наблюдается потрясающий озноб с резкими повышениями температуры до 40—41° и поаидающее падение температуры, сопровождающееся проливным потом. Общее состояние тяжелое, пульс слабый и частый. При чисто септических формах температура все время может оставаться на высоких цифрах (40—41°). Болезнь обычно имеет бурное начало, и по мере повторения ознобов состояние больных заметно ухудшается.

**Лечение.** При первых признаках отогенного сепсиса необходимо немедленно направить больного на операцию (широкое вскрытие сосцевидного отростка, обнажение и иссечение тромбозированной части синуса). Борьба с проникшей инфекцией: общий уход, сульфаниламиды по 1—2 г каждые 4 часа; пенициллин

по 50 000—75 000 единиц каждые 3 часа под кожу; внутривенные вливания хлористого кальция (0,5—1% раствор по 200—300 мл).

**СЕРНАЯ ПРОБКА (CERUMEN).** Повышенная секреция серных желез слухового прохода может привести к образованию закупоривающей слуховой проход серной пробки.

**Симптомы и течение.** Жалобы на внезапно наступающее резкое понижение слуха, обычно после купанья, мытья головы и вливания воды в ухо. При осмотре обнаруживают темнокоричневую массу, заполняющую просвет слухового прохода.

**Лечение.** Промывание водой слухового прохода при помощи 100-граммового шприца: оттягивают ушную раковину кзади и кверху и направляют струю теплой воды (температуры 37°) по задне-верхней стенке слухового прохода. Обычно пробка удаляется легко. Рекомендуются предварительно размягчить пробку вливанием капель из 5% раствора соды, которое производится в течение нескольких дней.

**СКЛЕРОМА ГОРТАНИ (SCLEROMA LARYNGIS).** Склерома — хроническое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Возбудитель склеромы — палочка Волковича-Фриша.

**Симптомы и течение.** Развиваются быстро рубцующиеся инфильтраты, поражающие слизистую оболочку носа, затем гортань, реже глотку и носоглотку. Склеромные инфильтраты ведут к сужению входа в нос, гортани, дыхательного горла и бронхов.

Распознавание основывается на характерном виде склеромных инфильтратов и рубцов, быстром развитии болезни и данных лабораторных исследований (серологические реакции, биопсия).

**Лечение.** С успехом применяется рентгено- и радийтерапия. Иссечение рубцов и сращений. При стенозах гортани и дыхательного горла — бужирование. В ранних стадиях помогает стрептомицин.

**ТОНИЛЛИТ (TONSILLITIS CHRONICA). ВОСПАЛЕНИЕ МИНДАЛИН ХРОНИЧЕСКОЕ.** Развивается в результате острых ангин. Процесс гнездится главным образом в лакунах миндалин. Плоский эпителий, слущиваясь и накапливаясь в лакунах, вместе с бактериями и лейкоцитами превращается в гнойный или творожистый распад с неприятным запахом, заполняющий в виде пробки лакуны.

**Симптомы и течение.** Жалобы на неприятное чувство в области миндалин, запах изо рта, иногда колющие боли, отдающие в ухо; увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов; нередко длительная субфебрильная температура; вялость, неспособность к труду, головные боли.

**Лечение.** В легких случаях — консервативное: щелочные (сода) полоскания и удаление пробок путем их вымывания или выдавливания тупым шпателем. В случаях с частыми ангинами и общих осложнений — хирургическое лечение.

**ТУБЕРКУЛЕЗ ГОРТАНИ (TUBERCULOSIS LARYNGIS).** Развивается, как правило, вторично у больных туберкулезом легких. Заражение происходит при оседании туберкулезной мокроты в трещинах слизистой гортани и местах слущивания эпителия, а также через кровеносные и лимфатические сосуды.

**Симптомы и течение.** Вначале обычно поражаются голосовые связки или межчерпаловидное пространство, что дает лишь ограниченную гиперемию одной истинной голосовой связки. Затем образуется инфильтрат, который в дальнейшем распадается и превращается в язву, увеличивающуюся в глубину и по поверхности. Воспалительно-некротический процесс часто захватывает надгортаннику и хрящи. Возникает отек гортани и резкое затруднение дыхания.

С появлением инфильтрата и язв голос становится хриплым, усиливается кашель, появляется болезненность при глотании, доходящая до резких степеней при изъязвлении надгортанника и черпаловидных хрящей.

**Лечение.** Молчание, вливание гортанным шприцем 2—5% ментолового масла (1—2 мл через день). Язвы прижигают после обезболивания трихлоруксусной, хромовой или молочной кислотой. Инфильтраты и язвы при соответствующих показаниях выжигают гальванокаутером. Инфильтраты могут быть также удалены кровавым путем. Общее лечение туберкулеза легких (искусственный пневмоторакс, климатическое лечение, усиленное общее питание и т. д.). Очень эффективным оказывается лечение туберкулеза легких и экссудативных острых и подострых процессов гортани стрептомицином при внутримышечном его введении. Большим успехом в лечении гортанно-легочного туберкулеза пользуется в последнее время парааминосалициловая кислота (ПАСК, см.). Оба эти средства во многих случаях применяют одновременно (лечение проводится в условиях врачебного стационара).

Необходимо следить за тем, чтобы больные не плевали на пол, а отхаркивали мокроту в специальные плевательницы.

**Профилактика.** Периодический осмотр гортани в туберкулезных диспансерах у болеющих туберкулезом легких, воздержание от курения, спиртных напитков, охлаждения и перенапряжения голоса.

**ФАРИНГИТ.** Воспаление слизистой оболочки глотки бывает острым и хроническим. Острые воспаления чаще всего возникают как нисходящий катарр носа и носоглотки.

**Симптомы.** Ощущение сухости, легкой болезненности и саднения в глотке. При осмотре слизистая красна, покрыта слизисто-гнойным секретом, иногда на задней стенке выступают отдельные красные зерна (воспаленные фолликулы).

**Лечение** то же, что и при ангине.

Хронический фарингит зависит от причин местного (хронические насморки, гнойные воспаления придаточных пазух носа, хронические тонзиллиты) и общего (болезни сердца, легких, печени, почек, обмена веществ и т. д.) характера. Различают катаральный, гипертрофический и атрофический фарингит.

**Симптомы.** При атрофической форме больные жалуются на першение, царапание и сухость в горле, при гипертрофической — на скопление в носоглотке вязкого слизистого отделяемого, необходимость частого откашливания и отхаркивания, особенно по утрам. При атрофическом фарингите слизистая суха, блестяща, как бы покрыта лаком; на ней нередко обнаруживают высохшую

слизь или корки. При гипертрофическом фарингите слизистая красна, утолщена и покрыта вязким слизисто-гнойным секретом.

**Лечение.** Устранение основных причин. Полоскание теплыми щелочными растворами (сода, буры и соли), смазывание глотки растворами (1—5%) ляписа (при гипертрофической форме) и иодглицерина (при атрофической, форме).

**ФРОНТИТ** см. *Воспаление придаточных пазух носа.*

**ФУРУНКУЛ (ЧИРЕЙ) НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА** (OTITIS EXTERNA ACUTA CIRCUMSCRIPTA). Вызывается внедрением стафилококка в волосные мешочки и сальные железы при расчесах и трещинах кожи. Располагается в хрящевой части слухового прохода.

**Симптомы и течение.** Сильная боль, часто отдающая в зубы, шею и усиливающаяся при жевании. Слуховой проход в хрящевой части резко сужен. Особенно болезненно надавливание на козелок и хрящевую часть слухового прохода. Температура может быть несколько повышена. Слух обычно нормален. Болезнь длится несколько дней, но нередко чирей рецидивирует, и болезнь затягивается на недели.

**Лечение.** Согревающий компресс, введение в слуховой проход узкого марлевого тампона, смоченного боровской жидкостью или 70% спиртом. Лучи кварцевой лампы, синий свет, соллюкс. При нагноении фурункула — вскрытие. Для предупреждения рецидивов — смазывание стенок слухового прохода борным спиртом, желтой ртутной мазью, особенно при наличии экземы кожи. При общем фурункулезе — укрепляющее лечение (железо, мышьяк, рыбий жир и т. д.).

**ФУРУНКУЛ НОСА** (TURUNCULUS NASI). Появляется в результате занесения стафилококковой инфекции в сальные и волосные мешочки. Нередко сочетается с общим фурункулезом.

**Симптомы и течение.** Резкая краснота на кончике или крыле носа, напряженность и болезненность при прикосновении, иногда повышенная температура.

**Лечение.** Ультрафиолетовое облучение, индифферентные мази, примочки из боровской жидкости и прием внутрь сульфаниламидных препаратов. При упорном фурункулезе необходимо общее укрепляющее лечение (мышьяк, железо). В тяжелых случаях и при переходе процесса на верхнюю губу назначают пенициллин (внутримышечно).

## ГЛАВА X ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

**АВИТАМИНОЗ' А** (AVITAMINOSIS A). Наступает вследствие недостатка в организме, плохой усвояемости или отсутствия в пище витамина А, который является антиксерофтальмическим фактором.

**Симптомы и течение.** Жалобы на ощущение присутствия инородного тела в глазу, сухость, затем боли, понижение и даже потерю зрения в сумерках (гемералопия — «куриная слепота»). Ухудшается эпителизация ран, понижается сопротивляемость организма при различных оперативных вмешательствах. Конъюнктив век суховат, легко берется в мелкие складки. В области глазной щели на конъюнктиве у роговицы серовато-белые пятнышки (напоминают пенку молока). В далеко зашедших случаях отмечаются язвы роговицы и даже расплавление ее.

**Лечение.** Насытить пищу витамином А: рыбий жир, сырая печень (200—300 г в день), сливочное масло, морковный сок, сырые овощи (шпинат, салат, капуста, брюква и т. п.), фрукты. Внутримышечно — екорифталмол (смесь рыбьего жира и персикового либо хлопкового масла) по 1 мл ежедневно, 50—40 инъекций (перед употреблением подогреть!). Общеукрепляющее лечение: мышьяк, стрихнин, гематоген, препараты фосфора, железа. При язвах роговицы направить больного к врачу-окулисту.

**АНЕСТЕЗИЯ В ГЛАЗНОЙ ПРАКТИКЕ.** При извлечении инородных тел из конъюнктивального мешка и особенно с роговицы доаточно одно-двукратного закапывания по 1—2 капли 0,1—0,5 или 1% Sol. Dicaini. Можно употреблять и Sol. Cocaini 2%, но кокаин — яд для эпителия роговицы (слущивает его), поэтому злоупотреблять им не следует. Под влиянием кратковременного купания эти вещества не портятся. Те же обезболивающие средства употребляют и при ожогах глаза, сильных болях, тушировании язв роговицы и т. \*п. ► '...'"

При операциях для инфильтрационной анестезии употребляют Sol. Novocaini 0,5—1—2%. На 1 мл раствора новокаина рекомендуется прибавлять одну каплю раствора адреналина (1 : 1 000).

**ВЛЕНОРРЕЯ** см. *Гонорейная влениоррея.*

**БЛЕФАРИТ СУХОЙ, ВОСПАЛЕНИЕ КРАЕВ ВЕК СУХОЕ** (BLEPHARITIS SICCA). **Общие причины.** Анемия, туберкулез желез (золотуха), болезни обмена, аллергия, глисты, плохие гигиенические условия. Местные причины: аномалии рефракции (главным образом дальнозоркость и астигматизм), конъюнктивит, заболевание слезных путей.

**Симптомы и течение.** Покраснение и утолщение краев век, чешуйки у корней ресниц, зуд, резь, утомление глаз, слезотечение. Течение заболевания хроническое.

**Лечение.** Прежде всего лечение основного заболевания; исправление (коррекция) аномалий рефракции. В случае обнаружения глистов — их удаление.

Закапывание 2 раза в день по 2 капли Sol. Zinci sulfurici 0,3% или Sol. Resorcini 2%, или Sol. Albucidi 20—20%.

Смазывание век 1% раствором бриллиантовой зелени на 70° спирту. На ночь смазывание краев век Ung. Hydrargyri oxydati flavi 1% или Ung. Norsulfasoli 5%.

**БЛЕФАРИТ ЯЗВЕННЫЙ (BLEPHARITIS ULCEROSA).** Причины. Туберкулез желез (золотуха), расстройства обмена веществ, аномалии рефракции.

Жалобы те же, что и при сухом блефарите. •

**Объективно.** Покраснение и утолщение краев век; гнойные корочки у корней ресниц, по снятии которых обнажаются кровоточащие язвочки. Последствия — стойкое выпадение ресниц, неправильный рост их, утолщение век. Заболевание упорное.

**Лечение.** Лечить общее заболевание. Общеукрепляющая терапия. Тканевая терапия по акад. В. П. Филатову (экстракт алоэ по 1—2 мл подкожно ежедневно 30—40 инъекций), внутримышечно — екорифталмол (Ecorophthalmol) по 1—2 мл ежедневно 30—40 инъекций и т. п. Корочки осторожно удалять ваткой, смоченной в растворе Sol. Hydrargyri oxydyanati 1 : 5 000, края век смазывать Sol. Brilliamgrun 1% или Sol. Argenti nitrici 2%.

Мази: Ung. Norsulfasolr 5%, Ung. Hydrargyri oxydati flavi 1—2%.

**БЛИЗОРУКОСТЬ (MYOPIA).** Симптомы — плохое зрение вдаль, при высоких степенях — «летающие мушки».

**Профилактика.** Работа при хорошем освещении, не читать лежа, соблюдать требования школьной гигиены.

**Лечение.** Коррекция вогнутыми стеклами (конкав) — наименьшим стеклом, которое обеспечивает больному наилучшее зрение. При осложнениях (миопических хориоретинитах) Sol. Pilocarpini 1%, Sol. Dionini 2—10% (постепенно повышая концентрацию), внутримышечные инъекции екорифталмола (смеси равных частей рыбьего жира и персикового масла) по 1 мл (30—40 инъекций), подкожные инъекции — экстракта алоэ по 1 мл (тканевая терапия по акад. В. П. Филатову). Внутрь препараты йода, витамины А, В, С и D. При отслойке сетчатки операция. При осложнениях близорукости больного направить к врачу-окулисту.

**ВОСПАЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (NEURITIS OPTICA).** Воспаление зрительного нерва — тяжелое заболевание, диагностируемое с помощью глазного зеркала (офтальмоскопа).

**Причины.** Общие заболевания (сифилис, туберкулез, малярия, грипп, отравление денатурированным и особенно древесным спиртом, заболевания придаточных пазух носа, бруцеллез).

**Симптомы и течение.** Значительное понижение зрения, иногда до полной слепоты. При исследовании офтальмоскопом — сосок зрительного нерва гиперемирован, в дальнейшем может наступить побледнение его (атрофия).

### III

**Лечение.** Заболевание зрительного нерва принадлежит к числу тяжелых и поэтому требует обязательного направления больного к специалисту-офтальмологу, для установления диагноза и назначения лечения.

При лечении заболеваний на почве сифилиса надо соблюдать осторожность в отношении применения ртути.

**ВОСПАЛЕНИЕ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ (IRITIS).** Причины. Сифилис, ревматизм, подагра, очаговая инфекция, туберкулез, гоноррея и другие заболевания.

**Симптомы и течение.** Сильные боли в глазу и голове, особенно по ночам. Светобоязнь, слезотечение, в дальнейшем может присоединиться ослабление зрения.

Гиперемия конъюнктивы, главным образом вокруг роговой оболочки, синевато-фиолетового оттенка. Изменение цвета радужной оболочки (сравнить со здоровым глазом). Узкий зрачок (важный признак!). Отложения на задней поверхности роговицы (преципитаты). Сращение края зрачка с хрусталиком (синехии).

Для ирита сифилитического и туберкулезного происхождения характерно образование узелков в радужной оболочке.

Болезнь длится не менее 6—8 недель. Ирит сифилитического или туберкулезного происхождения длится долее. Ириты часто рецидивируют, что ухудшает прогноз.

Туберкулезный ирит нередко приводит к слепоте вследствие помутнения хрусталика, а иногда и к атрофии глаза. Другие формы протекают благоприятнее.

Лечение причинное, т. е. оно должно быть направлено на устранение причины, вызвавшей заболевание.

**Общее лечение.** Внутримышечные инъекции пенициллина, разведенного в количестве 100 000 единиц в 1% растворе пирамидона, 2 раза в день или введение 2 раза в день 100 000 единиц препарата в зону тканевой геморагии (после кровососных банок), так называемое введение пенициллина с пролонгаторами. Препарат можно вводить и обычным путем по 30 000—50 000 единиц через 3 часа. В случаях туберкулезного ирита прибегают к инъекциям раствора стрептомицина в физиологическом растворе или в бидестил-лированной воде. Инъекции производят под конъюнктиву глазного яблока. Ежедневно или через день вводят по 0,025—0,05 г (25 000—50 000 единиц стрептомицина хлоркальциевого комплекса) в 0,5 мл растворителя. Рекомендуется внутривенное введение 40% уротропина по 10 мл каждый день, внутримышечно — введение молока, начиная с 1 мл, один раз в 2—3 дня. Дозу каждый раз повышают на 0,5—1 мл. Проводится санация рта. Внутрь назначают салициловый натрий по 0,5 два-три раза в день или уротропин по 0,3 два-три раза в день, при гонорройном ирите — сульфидин или сульфазол по 0,5 три раза в день. Местно: припарки, согревающие компрессы, синий свет, лампа соллюкс и т. п.

При болях показаны пилюльки на соответствующий висок.

В глаз закапывают Sol. Atropini 1% по 1—2 капли 3—4 раза в день, до расширения зрачка.

Зрачок надо держать в расширенном состоянии в течение всего периода раздражения.

В поздние периоды впускают Sol. Dionini 2—3% по 2 капли 1—2 раза в день. При сильных болях в глаз впускается Sol. morphini hydrochlorici 1% и Sol. Chinini hydrochlorici 1% 2—3 раза в день в подогретом виде.

**ВОСПАЛЕНИЕ СЕТЧАТКИ (RETINITIS).** П р и ч и н ы. Высокая злокачественная близорукость, воспаление почек, диабет, туберкулез, сифилис, гипертония.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Понижение зрения (иногда значительное), появление перед глазом «летающих мушек», темных пятен. Иногда большие перестают видеть в сумерках («куриная слепота»). Диагноз устанавливается с помощью глазного зеркала — офтальмоскопа. Необходимо исследование мочи на белок и сахар, а крови на реакцию Вассермана; реакция Пирке, измерение артериального давления.

**Л е ч е н и е.** Лечить по назначению врача-окулиста основное заболевание. Тканевая терапия (подкожные инъекции экстракта алоэ по 1—2 мл N. 30, внутримышечно екорифталмол и другие препараты). При явлениях «куриной слепоты» — сырая печень, рыбий жир. При злокачественной близорукости — коррекция очками, местно Sol. Dionini 2—10% по 2 капли, постепенно повышая концентрацию, на ночь Sol. Pilocarpini 1% (улучшает питание глаза). Избегать напряженной работы и работы с наклоненной головой. При ретинитах показано стационарное лечение.

**ВОСПАЛЕНИЕ СЛЕЗНОГО МЕШКА (DACRYOCYSTITIS).** Часто наблюдается при изменениях в полости носа (хронический насморк, искривление перегородки, рубцы и т. п.), которые вызывают непроходимость и застой в слезоотводящих путях.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Жалобы на слезотечение. При надавливании на область слезного мешка у внутреннего угла глаза из слезных точек выделяется капелька слизи (катаральный дакриоцистит — воспаление слезного мешка) или гноя (гнойный дакриоцистит). В запущенных случаях отмечается припухлость в области слезного мешка — эктазия (расширение) слезного мешка. В остром периоде — припухлость, гиперемия во внутреннем углу века. При флегмоне — резкая болезненность, гиперемия, значительная отечность, которая может переходить и на соседние участки кожи. Могут наблюдаться свищи слезного мешка.

**Л е ч е н и е.** В остром периоде — тепло (припарки, согревающий компресс, синий свет, УВЧ), в подострых и хронических случаях — операция. Операция необходима, так как пневмококк, наиболее частый возбудитель воспаления слезного мешка, нередко вызывает ползучую язву роговицы (ulcus corneae serpens) (см.).

В конъюнктивальный мешок вкапывают 2—3 раза в день Sol. Protargoli 2%, Sol. Collargoli 3%, Sol. Albucidi 30%.

**ВЫВОРОТ ВЕК (ECTROPION PALPEBRAE).** Наблюдается в пожилом возрасте вследствие атрофии круговой мышцы века и дряблости кожи (ectropion senile) или вследствие развития рубцов на коже века (после рожи, сибирской язвы, туберкулеза костей орбиты и т. п.) (ectropion cicatricis). В случаях паралича лицевого нерва развивается «заячий глаз» — невозможность закрыть веки (lago-phthalmus.)

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Существуют различные степени выворота века — от незначительного, еле заметного, до значительного, лишаящего возможности закрыть веки. Жалобы на слезотечение. При значительных выворотах век — высыхание роговицы, образование язв роговицы с последующим образованием бельма.

**Л е ч е н и е.** Оперативное. При вывороте слезной точки (основная жалоба — слезотечение) временно назначают средства, уменьшающие слезотечение.

Rp. Sol. Zinci sulfurici 0,25% 10,0 Sol.  
Adrenalini 1 : 1 000 gtt. X Novocaini  
0,2 MDS. По 2 капли 2—3 раза в день

**ГЛАЗНАЯ ПОВЯЗКА.** Глазную повязку накладывают для того, чтобы предохранить глаз от загрязнения, света или с лечебной целью (компресс) и т. п. Различают следующие виды глазных повязок.

**Занавеска.** Вокруг головы над бровями в горизонтальном направлении проводят один тур бинта, который фиксируют на лбу, свисающий над больным глазом кусок марли.

**Монокулярная повязка (повязка на один глаз).** На глаз накладывают кусок ваты, завернутый в марлю (не класть на глаз вату без марлевой прокладки!). Закрепив бинт круговым горизонтальным ходом через лоб и затылок, его спускают сзади с затылка вниз и ведут под ухом с больной стороны косо через щеку и вверх, закрывая больной глаз. Косой ход закрепляют круговым. Чередуя круговые и косые обороты, закрывают всю область больного глаза.

**Бинокулярная повязка (повязка на оба глаза).** Накладывается так же, как и монокулярная, но вместо второго (кругового хода) бинт проводят от затылка через теменной бугор на второй глаз. Таким образом, все время бинтуют так: один оборот бинта накладывают на один глаз, второй — на другой глаз.

**ГЛАУКОМА (ПЕРВИЧНАЯ) (GLAUCOMA).** П р и ч и н а глаукомы не известна. Среди причин слепоты глаукома стоит на первом месте.

Главные признаки глаукомы — повышенное внутриглазное давление, снижение зрительных функций и изменения в соске зрительного нерва. Диагноз глаукомы может установить только врач-окулист методами специальных исследований.

Глаукома бывает воспалительная и простая.

Воспалительная глаукома проявляется либо остро, либо имеет хроническое течение.

**С и м п т о м ы.** При острой воспалительной глаукоме (приступ глаукомы) возникает внезапная, очень сильная боль в глазу и голове; отмечается тошнота, иногда рвота, падение зрения.

**О б ъ е к т и в н о .** Застойная (синеватая) гиперемия конъюнктивы, главным образом у роговицы, легкое помутнение последней вследствие отека (поверхность роговицы напоминает запотелое стекло). Широкий зрачок (по спутать с притом, при котором отмечается узкий зрачок!), мелкая передняя камера, твердый наощупь глаз.



При хронической воспалительной глаукоме больной жалуется на легкую боль в глазу и голове, затуманивание, радужные круги при взгляде на отдаленный источник света, падение зрения.

**Объективно.** Твердый наощупь глаз, широкий зрачок, застойные вены около роговицы. На глазном дне при исследовании офтальмоскопом экскавация (углубление) соска зрительного нерва.

При простой глаукоме субъективные жалобы и изменения в переднем отрезке глазного яблока отсутствуют. Имеется более или менее высокое внутриглазное давление, экскавация (углубление) соска зрительного нерва и падение функций глаза (центрального и периферического зрения).

**Лечение.** При приступе глаукомы — горячая ножная ванна, пиявки на висок (2—3 штуки), слабительные соли или клизма. Ограничение употребления жидкостей, главным образом кофе и чая. Внутрь назначают бром, люминал, хлоралгидрат (см.).

В глаз каждый час впускают Sol. Pilocarpini 1%, а для обезболивания — Sol. Chinini hydrochlorici 1% + Sol. Morphini hydrochlorici 1% в теплом виде по 3—4 капли.

Если лечение не помогает, необходима операция, которую нельзя откладывать.

**Лечение хронической глаукомы.** Гигиенический режим, покой, ограничение употребления жидкостей, главным образом кофе и чая. Избегать запоров, переполнения кишечника. Запрещаются все спиртные напитки. Внутрь систематически дают препараты йода (см.), небольшие дозы бромидов (Kalii seu Natrii bromati 1,0, Coffeini natrio-benzoici 0,5, Aq. destill. 200,0. DS. По столовой ложке 2 раза в день).

Систематическое впускание в глаз Sol. Pilocarpini 1% или Sol. Proserini 0,25%, или Sol. Eserini salicylici 0,25%. Больной должен находиться под систематическим наблюдением врача-окулиста. Надо следить за функциями глаза; если зрение падает, необходима операция.

**ГЛАУКОМА ВТОРИЧНАЯ (GLAUCOMA SECUNDARIA).** Повышение внутриглазного давления в результате каких-либо видимых причин, в большинстве случаев причин, затрудняющих отток жидкостей из глаза (спаянное бельмо роговицы, «оржавление» глаза, кровоизлияние в глаз и т. п.).

**Симптомы и лечение** те же, что и при первичной глаукоме (см.).

**ГЛИОМА СЕТЧАТКИ (GLIOMA RETINAE).** Злокачественное новообразование сетчатки. Наблюдается в раннем детском возрасте, до 3—5 лет.

**Симптомы и течение.** Зрачок становится желтовато-серым («кошачий глаз»), ребенок быстро теряет зрение. Опухоль растет быстро, прорастая все оболочки глаза, и распространяется по зрительному нерву в полость черепа. Вскоре может развиваться экзофтальм (выпячивание глаза).

Заболевание обычно двустороннее. Диагноз в начальных стадиях ставится специалистом-окулистом методом офтальмоскопии.

**Лечение.** Ввиду злокачественности опухоли, требуется спешная операция (удаление глаза).

### ГОНОВЛЕНОРРЕЯ (GONOBLENNORRHOEA CONJUNCTIVAE).

Гонорройное воспаление соединительной оболочки глаза. Различают две формы: гоновленоррея новорожденных и гоновленоррея взрослых.

Гоновленоррея новорожденных возникает в результате заражения ребенка во время прохождения его через родовые пути матери, больной гонорреей, и поражает обычно оба глаза.

Гоновленоррея взрослых возникает либо у больных гонорреей в результате самозаражения, либо через соприкосновение с загрязненными гонорройным секретом предметами. Она бывает часто односторонней.

**Симптомы и течение.** Резкий отек век, отек и гиперемия конъюнктивы, обильное отделяемое — вначале сукровичное (3—5 дней), а затем гнойное. В поздних стадиях может возникнуть язва роговицы. Исход: если была язва роговицы, остается бельмо.

**Профилактика новорожденных** по Матвееву у (метод, ошибочно приписываемый Креде). Веки новорожденного тщательно протирают ватным тампоном, после чего в каждый глаз впускают по одной капле свежеприготовленного 2% раствора ляписа (Sol. Argenti nitrici 2%). Не промывать глаза после впускания капель!

**Лечение.** Конъюнктиву присыпают порошком альбумида каждые 3 часа круглосуточно (после предварительного промывания конъюнктивального мешка раствором марганцовокислого калия 1 : 5 000) или впускают 30% раствор альбумида. Вместо альбумида каждые 3 часа можно закладывать Ung. Sulfidini 2%. Рекомендуется закапывать каждый час без перерыва на ночь раствор пенициллина (10 000 единиц в 1 мл; 100 000 единиц растворить в 10 мл физиологического раствора). Каждые 3—4 дня готовить свежий раствор. Сохранять в прохладном месте.

При отсутствии этих препаратов — промывать через каждый час Sol. Kalii hypermanganici 1 : 5 000. В детской практике раствор должен быть теплым. Прижигание 1—2% Sol. Argenti nitrici один раз в день: выворачивают оба века и, сближая их, защищают роговицу, затем орошают раствором ляписа вывернутую конъюнктиву, избыток раствора смывают физиологическим раствором или же дистиллированной водой. На ночь закладывают Ung. Collargoli 5%.

Для предохранения от появления язвы роговицы один раз в день впускают Sol. Eserini salicylici 0,25% или Sol. Pilocarpini muriatici 1%. Соблюдение правил общей и личной гигиены. Чтобы не попала инфекция во второй, здоровый, глаз, взрослым накладывают на этот глаз часовое стекло, края которого прикрепляют к коже липким пластырем. В случае появления язвы роговицы больного немедленно направить к врачу-окулисту.

**ГРАДИНА (CHALAZION).** Невоспалительная ограниченная припухлость в толще века. Наступает обычно вследствие закупорки выводных протоков мейбомиевой сальной железы, расположенной в толще хряща века.

**Симптомы и течение.** Ограниченная, не спаивающаяся с кожей века припухлость величиной с горошину, иногда просвечивающая

через конъюнктиву хряща. Может существовать годами, то увеличиваясь, то уменьшаясь.

**Лечение.** Иногда помогает массаж с Ung. Hydrargyri oxy-dati flavi 1% (мазь закладывают на почку в конъюнктивальный мешок, после чего больной пальцем через кожу массирует градину). Если рассасывание не наступило, прибегают к оперативному удалению. В молодом возрасте операция производится больше с косметической целью, в пожилом изредка наблюдается злокачественное перерождение, а поэтому удаление градины обязательно.

**ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ (HYPERMETROPIA).** Врожденное предрасположение к аномалии - рефракции (понижение преломляющей способности сред глаза или уменьшение его передне-заднего диаметра).

**Симптомы.** Жалобы на быструю утомляемость глаз при работе, головные боли, при высоких степенях — понижение зрения. Часто предрасполагает к блефаритам, хроническим конъюнктивитам.

**Лечение.** Коррекция выпуклыми стеклами (копекс) — наивысшим номером, который переносит больной. При дальнорзости, осложненной блефаро-конъюнктивитом, выпуклые стекла назначают для постоянного ношения. После удаления катаракты (афакия) получается дальнорзость, которую исправляют выпуклыми стеклами + 10,0—12,0 D.

**ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ СТАРЧЕСКАЯ (PRESBYOPIA).** Развивается обычно после 40—45 лет вследствие уплотнения ядра хрусталика, что затрудняет аккомодацию (способность глаза приспособляться к зрению на разное расстояние).

**Симптомы и течение.** Затруднение или невозможность работы на близком расстоянии при сохранившемся зрении вдаль.

**Лечение.** Врач-окулист назначает выпуклые стекла (кон-векс) для работы.

**ЗАСТОЙ СОСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (OEDEMA PAPILLAE N. OPTICI).** Причины. Опухоли мозга и глазницы, гипертония, воспаление почек.

**Симптомы.** Незначительное понижение зрения, чувство неловкости, головные боли. Диагноз устанавливается офтальмоскопически (исследование глазным зеркалом) — гиперемия, отечность соска, перегиб сосудов у его края (сосок выдается вперед в виде гриба), отек сетчатки.

**Лечение.** Необходимо срочно направить больного к специалисту, так как застойный сосок — признак тяжелого заболевания.

**ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ** могут развиваться как в глазном яблоке, так и в его придатках.

Кожа век поражается часто; вначале здесь развивается ограниченная припухлость, которая вскоре изъязвляется, края ее плотные. Опухоль растет обычно медленно и захватывает все новые отделы; может прорастать всю орбиту и придаточные полости носа.

Конъюнктив поражается редко, в большинстве случаев опухолями, которые переходят с век. Иногда развиваются более злокачественные пигментированные опухоли.

В радужной оболочке могут развиваться меланосаркомы — из родимых пятен радужки (они имеются почти у каждого человека). Эти родимые пятнышки радужки иногда начинают медленно расти. Необходимо тщательное наблюдение за подобными родимыми пятнышками радужки, которые, по словам больного или его близких, начинают увеличиваться.

В сосудистой оболочке встречается меланосаркома. В детском возрасте в сетчатке образуется глиома (см.). Эти новообразования диагностируются с помощью офтальмоскопии (исследования глазным зеркалом). При диагностировании исключить сифилис, туберкулез (!).

**Лечение.** Возможно ранняя операция с последующей рент-гено- или радийтерапией.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗ.** Выворачивание верхнего века. Больной смотрит вниз или на кончик собственного носа. Большим и указательным пальцем правой руки захватывают ресничный край верхнего века вместе с ресницами и оттягивают его вниз и несколько вперед. Большой или указательный палец левой руки или стеклянную палочку ставят ребром по верхнему краю хряща и, отодвигая его книзу, выворачивают веко. Чтобы поставить веко на место, больному предлагают посмотреть вверх. Если больной не смотрит вниз, вывернуть веко не удастся (!).

**Исследование при боковом освещении.** Исследование производится в темной комнате. Слева несколько впереди от больного ставят источник света. В правую руку берут лупу (лучше силой в 13,0 D), фокус которой направляют на исследуемое место глаза, а через другую лупу (лучше силой в 20,0 D) рассматривают освещенный участок.

**Исследование в проходящем свете.** Исследование производят в темной комнате. Источник света находится сбоку и несколько впереди от больного. Производящий исследование держит офтальмоскоп перед своим правым глазом (левый глаз рекомендуется держать закрытым) и рассматривает глаз больного через отверстие в офтальмоскопе. Отраженные от зеркала лучи («зайчик») отбрасываются на глаз больного. При прозрачных преломляющих средах зрачок как бы загорается красным-светом. Помутнеть в прозрачных средах глаза (хрусталик, стекловидное тело) будут темного цвета. Форма включений зависит от формы помутнения.

**КАТАРАКТА- ПОМУТНЕНИЕ ХРУСТАЛИКА (CATARACTA).** Причины развития катаракты неизвестны. Зонулярную (врожденную) катаракту связывают с рахитом.

Катаракта встречается чаще в пожилом возрасте в форме так называемой старческой катаракты (cataracta senilis). В молодом и детском возрасте катаракта встречается значительно реже. Наиболее частой формой катаракты молодого и детского возраста является так называемая зонулярная катаракта (cataracta sonularis). Кроме того, могут быть врожденные катаракты и другого характера.

**Симптомы и течение.** Постепенное падение зрения. Объективно: помутнение хрусталика; постепенно изменяется цвет зрачка, который становится серым, а не черным, как в норме.

Помутнение хрусталика возникает постепенно, поэтому заметного изменения цвета зрачка вначале может и не быть, вначале не бывает и выраженного понижения зрения. Болезнь развивается медленно; в старческом возрасте процесс может длиться годами.

**Лечение.** Оперативное удаление катаракты. Оперировать катаракту можно лишь при условии, если сохранилась способность видеть свет. Если больной не видит света и не может указать направление, откуда он исходит, это указывает на то, что у него, кроме помутнения хрусталика, имеются еще и другие заболевания. Оперировать в этих случаях не имеет смысла.

При начальных катарактах внутрь назначают препараты иода (Т-гае Jodi 5%) от 2 до 10 капель на молоко после еды, постепенно повышая дозу; люголевский раствор (Jodi puri 0,02, Kalii jodati 0,2, Aq. destill. 20,0) по такой же схеме; хорошее действие оказывает 3% раствор йодистого калия, который принимают по столовой ложке после еды, или иодгиперсол, принимаемый по  $\frac{1}{4}$  чайной ложки перед едой. Все препараты иода принимают 2—3 раза в день. Витамин — внутрь. В конъюнктивальный мешок вводят капли Sol. Acidi ascorbinici 2% на 3% растворе глюкозы 2—3 раза в день, чистый или в сочетании с 2% раствором йодистого калия.

Rp. Kalii jodati 0,2

Ac. ascorbinici 0,1—0,2 Sol. Glucosae 3%  
10,0 DS. По 2 капли 2—3 раза в день в  
больной глаз

**КЕРАТИТ ПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ (KERATITIS PARENCHYMATOSA).** Причины. Чаще всего врожденный сифилис, реже — туберкулез и другие инфекционные заболевания. Развивается обычно в возрасте 5—20 лет. Заболевают оба глаза часто не одновременно, а через некоторый промежуток.

**Симптомы и течение.** Гиперемия конъюнктивы вокруг роговицы (с синюшным оттенком). Помутнение роговицы в глубоких слоях ее (поверхность ее напоминает матовое или запотевшее стекло). Быстро развиваются новообразованные сосуды в глубоких слоях роговицы. Радужная оболочка раздражена. Болезнь нарастает в течение 6—8 недель, затем до 2 лет может наблюдаться просветление роговицы. Болезнь нередко сопровождается тугоухостью, неправильным развитием верхних резцов (гутчинсоновская триада). Изъязвления роговицы не бывает.

**Лечение.** Исследование крови больного и членов семьи на реакцию Вассермана. В случае положительной реакции специфическое противосифилитическое лечение — пенициллин до 8 000 000 единиц, биохинол. Особенно хороший эффект дает втирание серой ртутной мази. Местно назначают тепло, Sol. Atropini sulfurici 1% несколько раз в день по 1—2 капли. Чтобы атропин не попадал в носоглотку и не проглатывался, больной в течение 10 минут надавливает указательным пальцем на внутренний угол глаза (на область слезного мешка). В период рассасывания помутнения вводят Sol. Dionini 2—10% (концентрацию постепенно повышают) по 1—2 капли 3 раза в день, мазь из желтой осадочной ртути (1—2%). Тканевая

терапия по акад. В. П. Филатову (экстракт алоэ по 1 мл N. 30, подкожно, подсадка консервированной на холоду кожи и т. п.). В случаях стойких бельм роговицы — оперативное вмешательство (искусственный зрачок, пересадка роговицы по акад. В. П. Филатову).

Rp. Hydrargyri oxydati flavi 0,1 Aq.  
destill. gtt. IV Vaselini puri 10,0  
Mf. Ung. DS. За веки 2 раза в  
день

**КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТ СКРОФУЛЕЗНЫЙ (KERATO-CONJUNCTIVITIS SCROPHULOSA).** Туберкулезное (золотушное) воспаление роговицы и конъюнктивы. Причины. Заболевание наблюдается у детей с туберкулезом желез и относится к группе аллергических заболеваний. Возникновению его часто способствует туберкулезная интоксикация, а также интоксикация со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно аскаридоз.

**Симптомы и течение.** Часто экзема кожи лица. Явления общего скрофулеза: увеличение желез, положительная реакция Пирке. Светобоязнь, слезотечение, сильный спазм век. На конъюнктиве и роговице, чаще у лимба, мелкие узелки (фликтены), которые вскоре распадаются, заживая на конъюнктиве без следа, а на роговице с образованием рубцов (бельмо).

**Лечение.** Общее: внутрь рыбий жир, Sol. Calcii chlorati 20,0 на 200,0 воды 2 раза в день по столовой ложке. Облучение кварцем (осторожно!). В случае обнаружения в кале яиц аскарид — удаление глистов. Внутримышечные инъекции екорифталмола (смесь в равных частях рыбьего жира и персикового масла) по 1—2 мл, в течение 30 дней. Внутримышечные инъекции по 0,5—1—1,5 и 2 мл 0,25% раствора хлористого кальция, 20—30 дней; подкожно экстракт алоэ по 1 мл, 30—40 инъекций.

Рациональное, богатое витаминами питание (сливочное масло, молоко, свежие фрукты, овощи: морковь, капуста, брюква и т. п.). Местно. Вкапывать в конъюнктивальный мешок каждые 2—3 часа капли стрептомицина 0,1 (100 000 единиц сернокислого стрептомицина растворить в 10 мл физиологического раствора или биде-стиллированной воды). Иногда хорошо помогают пенициллиновые капли (100 000 единиц пенициллина растворить в 10 мл физиологического раствора), которые вводят через 2—3 часа в конъюнктивальный мешок. Закладывать мазь из 1% желтой осадочной ртути 2 раза в день. Закапывать Sol.- Resorcini 2% 2 раза в день по 2 капли. При резкой гиперемии конъюнктивы глазного яблока вокруг роговицы впускать Sol. Atropini sulfurici 1% два раза в день. Лечить экзему кожи — смазывать 1% спиртовым раствором бриллиантовой зелени, присыпать белым стрептоцидом. Мокнувшие участки кожи прижигать 2—5% раствором ляписа. Очень рекомендуется введение капель в конъюнктивальный мешок. Rp. Sol. Zinci sulfurici 1/3% 10,0 Resorcini 0,2

Sol. Adrenalini 1:1000 gtt.X DS. По 2 капли 3—4  
раза в день в оба глаза

### КОНЬЮНКТИВИТ ДИФТЕРИЙНЫЙ (DYPHTHERIA CONJUNCTIVAE, CONJUNCTIVITIS DYPHTHERICA).

Воспаление соединительной оболочки глаз, вызванное палочкой Леффлера.

**Симптомы и течение.** Очень сильный отек век; образование пленок на поверхности конъюнктивы, по снятии которых обнажается кровоточащая поверхность. В конъюнктивальном секрете палочки Леффлера. В поздние периоды заболевания может развиваться язва роговицы.

**Лечение.** Немедленно ввести антидифтерийную сыворотку в количестве не менее 6 000—10 000 единиц. Глаза промывать нераздражающими растворами (3% раствор борной кислоты, Sol. Hydrargyri oxysulfatis 1 : 6 000). В глаз 2 раза в день закладывать Ung. Xeroformi 3%. При язве роговицы впускать 2 раза в день Sol. Eserini salicylic! 0,25% или Sol. Pilocarpini 1%, или Sol. Proserini 0,2%. Больного немедленно помещать в инфекционную больницу (не в глазную!).

**КОНЬЮНКТИВИТ ОСТРЫЙ, ИНФЕКЦИОННЫЙ. ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ (CONJUNCTIVITIS ACUTA).** Возникает вследствие попадания в конъюнктивальный мешок гнойной инфекции: стафило-, стрепто- или пневмококков, палочки Коха-Викса и др.

**Симптомы и течение.** Отек и гиперемия век и слизистой оболочки глаза, иногда кровоизлияния в ней, слезотечение, склеивание краев век гноем, главным образом после сна.

**Лечение.** Промывать глаза несколько раз в день теплым раствором Sol. Hydrargyri cyanati (или Oxysulfatis) 1 : 5 000—8 000, Sol. Kali permanganici 1 : 5 000. Прижигать вывернутые веки Sol. Argenti nitrici 1—2% (смыть избыток 1% раствором хлористого натрия). Вместо прижигания можно впускать в глаза белковые препараты серебра (Sol. Collargoli 3—5%, Sol. Protargoli 2—3%) 2—3 раза в день по 2 капли, Sol. Albucidi 30%, Ung. Sulfidini 2%; кроме того, каждые два часа рекомендуется вводить в глаз раствор пенициллина — 100 000 единиц в 10 мл физиологического раствора. Раствор надо менять через 3—4 дня.

**КОНЬЮНКТИВИТ Фолликулярный (CONJUNCTIVITIS FOLLICULARIS).** Хроническое заболевание конъюнктивы у лиц, находящихся в плохих санитарно-гигиенических условиях (пыльное помещение, работа при плохом освещении и т. п.), а также у лиц, страдающих глистами, заболеваниями носа, аллергическими заболеваниями и т. п.

**Симптомы и течение.** Ощущение присутствия инородного тела, песка в глазах. Чаще всего в конъюнктиве нижних переходных складок и в углах конъюнктивы верхних век появляются мелкие, реже крупные зерна (фолликулы). Лежат эти зерна поверхностно, конъюнктива между ними не изменена (этим они отличаются от трахимальных фолликулов, которые лежат глубоко и ткань между ними инфильтрирована). Заболевание протекает длительно и бесследно проходит, чем и отличается от трахомы (см.), при которой фолликулы обязательно замещаются рубцовой тканью.

**Лечение.** Оздоровление общегигиенических условий труда и быта. Общеукрепляющее лечение (особенно у детей), изгнание глистов (если они обнаружены). Местно: Sol. Zinci sulfurici 0,3%, или по следующей прописи:

Rp. Zinci sulfurici 0,03  
Aluminis cristallisati 0,1  
Sol. Acidi borici 3% 10,0  
MDS. По 2—3 капли 3 раза в день.

Рекомендуется смазывать вывернутую конъюнктиву век кристаллом квасцов (Alumenstift — белый камень). На ночь за веки закладывают Ung. Hydrargyri oxydati flavi 1%.

**КОНЬЮНКТИВИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (CONJUNCTIVITIS CATTARRHALIS CHRONICA).** Часто развивается при аномалии рефракции (особенно в случаях дальнозоркости), пребывании в плохих санитарных условиях (пыль, дым). Часто бывает при аскаридозе. Встречается и как профессиональное заболевание у мукомолов, пекарей, на льнозаводах, в деревообделочной и химической промышленности.

**Симптомы и течение.** Жалобы на быструю утомляемость зрения, особенно при искусственном освещении, ощущение песка под веками, иногда небольшое слизистое отделяемое. Конъюнктивальный мешок гиперемизирован, бархатист. Нередко имеется и блефарит (см.).

**Лечение.** Устранить причину (меры личной и общественной гигиены), прописать корректирующие или защитные очки (консервы). Рациональное питание — пища, богатая витаминами, особенно витамином А (рыбий жир, морковь и т. п.). В случае обнаружения в кале яиц глистов — удаление паразитов. Необходимо исключить интоксикацию со стороны желудочно-кишечного тракта (запоры).

Местно — в конъюнктивальный мешок:

Rp. Zinci sulfurici 0,03  
Aluminis cristallisati 0,1 (или Resorcini 0,2) Sol. Adrenalinii 1 : 1  
000 gtt. X Sol. Acidi borici 3% 10,0  
MDS. Глазные капли

Вяжущие — Sol. Zinci sulfurici 0,25—0,5%, Sol. Aluminis cristallisati 1%. HS ночь можно закладывать за веки 1% мазь из желтой осадочной ртути (см.), Sol. Protargoli 2—3%. Глазная примочка из Sol. hydrargyri cyanati (или oxysulfatis) 1 : 5 000—1 : 8 000 или из крепкого чая. Средства необходимо менять.

**КОСОГЛАЗИЕ (STRABISMUS). Причины.** Часто врожденный дефект вследствие слабости, недоразвития или повреждения мышц глаза. Различают косоглазие содружественное и паралитическое (глаз не двигается в сторону парализованной мышцы). Причиной содружественного косоглазия нередко бывают аномалии рефракции, паралитического косоглазия — отравление (алкоголь, свинец, ботулизм), инфекционные болезни (особенно дифтерия,

грипп), травмы. Изолированный паралич отводящей мышцы глаза обычно бывает при сифилисе.

**Симптомы и течение.** Отклонение глаза в сторону или вверх, вниз. При внезапно наступившем косоглазии — двоение.

**Лечение.** Исправить обнаруженную аномалию рефракции очками для постоянного ношения. У детей упражнять косящий глаз (завязывать здоровый глаз, проводить упражнения со стереоскопом). При паралитическом косоглазии назначают причинное лечение, при стойком косоглазии производят операцию. Детей моложе 13—15 лет оперировать не рекомендуется.

**КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПОД КОНЬЮНКТИВУ (HAEMORRHAGIA SUBCONJUNCTIVALIS)** наступает неожиданно при сильных напряжениях и приливах крови к голове (сильный кашель, например, коклюш; рвота, запор и т. п.).

**Симптомы и течение.** Ярkokрасные пятна (кровь) разной величины и формы под конъюнктивой глаза. Рассасываются через 1—2 недели, не оставляя следов.

**Лечение** не требуется.

**КРЫЛОВИДНАЯ ПЛЕВА (PTERYGIUM).** Развивается обычно в пожилом возрасте у лиц, проживающих в местностях с плохими климатическими условиями (пыль, холод, ветер).

**Симптомы и течение.** Треугольная складка конъюнктивы, которая нарастает на прозрачную роговицу. Чаше надвигается на нее с внутренней стороны (pterygium internum), реже — с наружной стороны (pterygium externum). Когда плева зайдет за половину роговицы, наступает нарушение зрения.

**Лечение.** Оперативное.

**КУРИНАЯ СЛЕПОТА** см. *Авитаминоз А.*

**ОЖОГИ ГЛАЗ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИЕЙ (OPHTHALMIA ELECTRICA)** наступают при работе во время электросварки, при облучении кварцем без защитных очков и т. п., во время пребывания в солнечный день на горных ледниках, снеговых вершинах или вообще среди снежных пространств (действие ультрафиолетовых лучей).

**Симптомы и течение.** Через 6—7 часов после воздействия на глаз лучистой энергии появляется слезотечение, резкая боль, светобоязнь. Объективно — небольшое раздражение конъюнктивы, особенно в области глазной щели, слущивание эпителия роговицы. Очень редко — изменения глазного дна.

**Лечение.** Покой, холодные примочки, Sol. Dicaini 0,5—1% в глаз. Поместить больного в темную комнату.

**Профилактика.** Ношение защитных очков из темного стекла (консервы).

**ОЖОГИ ГЛАЗ ТЕРМИЧЕСКИЕ.** **Симптомы и течение.** Боль, слезотечение, падение зрения. Отек век, образование пузырей на коже век, отек и гиперемия конъюнктивы, помутнение роговицы. При тяжелых ожогах конъюнктивы бледная, анемичная, иногда фарфоровобелая. В дальнейшем может появиться некроз кожи век и конъюнктивы, а также язва роговицы. Исходы — образование рубцов, вывороты век, бельмо роговицы.

**Лечение.** Удаление частиц, причинивших ожоги (металл и т. д.), если таковые имеются. В глаз каждый час закапывать

01. Vaselini sterilisata или 01. Jecoris Aselli, закладывать каждые 3 часа Ung. Albucidi 30% или Ung. Xeroformii 3—5%.

Срочно после оказания первой помощи направить больного к специалисту.

**ОЖОГИ ГЛАЗ ХИМИЧЕСКИЕ И ОВ.** **Симптомы и течение** те же, что и при термических ожогах (см.). Рано появляется некроз и отторжение некротических участков тканей. Роговица фарфоровобелая, в дальнейшем появляется язва роговицы. Исходы — образование рубцов, сращение век с глазным яблоком, бельмо роговицы.

**Лечение.** Немедленно тщательно промыть глаз обильным количеством воды или 2% раствором соды.

В глаз впускать 01. Vaselini sterilisata каждый час. При болях Sol. Dicaini 0,5%. Особенно опасны ожоги щелочами. После оказания первой помощи срочно направить больного к специалисту! При ожогах глаз химическим карандашом удалить частицы карандаша, в глаз впускать Sol. Tannini 3% — первые полчаса через 5—10 минут, затем 3—4 раза в день.

**ОПУЩЕНИЕ ВЕРХНЕГО ВЕКА (PTOSIS)** обычно бывает врожденным вследствие недоразвития мышцы, реже приобретенным вследствие паралича нерва.

**Симптомы и течение.** При спокойном взгляде вперед верхнее веко прикрывает больше верхней трети рс.~ звицы (в норме — только верхнюю треть ее), поднятие века почти или совсем невозможно (незначительное поднятие века возможно только при напряжении мышц лба).

**Лечение.** Только оперативное.

**ОСМОТР ГЛАЗ У ДЕТЕЙ.** Помощник (мать, няня) кладет ребенка к себе на колени головой вперед, ноги ребенка выше колен прижимает локтем к своей груди, а руками удерживает его руки. Голова ребенка зажимается в слегка раздвинутых коленях исследующего. Глазную щель о с т о р о ж н о раскрывают векоподъемником или в крайнем случае приподнимают лопаточкой стеклянной палочки. При раскрывании глазной щели производящий исследование не должен низко наклоняться к лицу ребенка, так как содержимое конъюнктивального мешка может брызнуть ему в лицо.

**ОФТАЛМИЯ СИМПАТИЧЕСКАЯ** см. *Симпатическое воспаление.*

**ОФТАЛМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ** см. *Ожоги, лучистой энергией.*

**ОЧКИ.** Различают стекла, собирающие свет (конвекс, +), и стекла, рассеивающие свет (конкав, —). Стекла конвекс употребляются для коррекции дальнозоркости (см.), стекла конкав — для исправления близорукости (см.). Переднюю выпуклую поверхность стекла легко оцарапать, а поэтому очки надо хранить в плотном футляре и протирать чистой, несколько раз стиранной полотняной тряпочкой. Сила оптических стекол исчисляется в диоптриях (D). Одна диоптрия — ■ стекло, фокусное расстояние которого равно 1 м.

**ПАНОФТАЛМИТ (PANOPHTHALMITIS)** — гнойное воспаление всех оболочек глаза.

**Причины.** Чаше всего ранение глаза с попаданием инфекции во время ранения или после него, иногда перенос инфекции из гнойного очага.

**Симптомы и течение.** Сильные боли в глазу и голове, повышение температуры, отек конъюнктивы глаза (хемоз), выпячивание глазного яблока (exophthalmus). В передней камере глаза — желтый гной.

**Лечение.** Тепло (компресс, припарки, синий свет) применять несколько раз в день по 10—15 минут. Внутрь стрептоцид или сульфидин по 0,3—0,5—1 г три-пять раз в день. Пенициллин по 20 000—30 000 единиц через 4 часа внутримышечно (без перерыва на ночь) несколько дней подряд. Можно вводить пенициллин, разведенный в 1% растворе пирамидона (по 100 000 единиц два раза в сутки), или пенициллин, разведенный в физиологическом растворе, в зону тканевой геморрагии (место, где была поставлена кровососная банка) через 12 часов после банок.

При нарастании явлений надо срочно направить больного к специалисту.

**ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ МЕХАНИЧЕСКИЕ.** Механические повреждения глаз могут быть непрободными и прободными. Повреждения глаз могут сопровождаться внедрением инородного тела в ткани глаза. Чаще всего это мелкие инородные тела (песчинки, уголь, мелкие металлические стружки и т. д.). Они застревают в конъюнктиве верхнего века глаза и в роговице. Под верхним веком соринка обычно располагается в желобке, который имеется на внутренней поверхности века, недалеко от его края.

**Симптомы и течение.** Ощущение присутствия инородного тела, слезотечение. Инородное тело на слизистой века (вывернуть веко и осмотреть его с лупой) или на поверхности роговицы (осмотр с лупой).

**Лечение.** Впустить в глаз 0,1—0,5—1% раствор дикаина один раз или 2—3% раствор кокаина один-два раза. Инородное тело удалить ваткой, туго свернутой в форме палочки и смоченной дезинфицирующим раствором. С роговицы инородное тело удаляют иглой для удаления инородных тел или глазным долотом. После удаления впустить в глаз Sol. Chinini muriatci 1% или Sol. Collargoli 3% и за веки заложить Ung. Xeroformii 3% или Ung. Sulfidini 2%. Если инородное тело лежало на роговице, после его удаления глаз следует завязать.

Больной должен быть осмотрен на следующий день. При появлении инфильтрата роговицы на месте удаленного инородного тела впустить в глаз Sol. Atropini sulfurici 1% по 1—2 капли, Sol. Albucidi 30% 3—4 раза в день или раствор пенициллина 100 000 единиц в 10 мл физиологического раствора каждые 2—3 часа (см. также *Язва роговицы*), заложить за веки Ung. Sulfidini 2% или Ung. Xeroformii 3—5%, или Ung. Streptocidi 2% и направить больного к окулисту.

**ПРОТЕЗ ГЛАЗНОЙ.** Применяется, почти как правило, «ре<sup>а</sup> форм-протез» — протез, образованный из полого шара, одна стенка которого вдавлена внутрь. На выпуклой поверхности его изображен передний отрезок глаза. Сверху протеза имеется небольшая выемка для блока глазницы. Внутренний угол протеза острый, наружный закруглен (это позволяет определить, для какого глаза предназначен протез, — надо, чтобы выемка была направлена вверх, а острый

угол — к носу). Вставляя протез, более острый конец его подводят под верхнее веко, а тупой конец поворачивают к виску. Протез удерживается веками. На ночь протез снимают (над постелью, над подушкой, чтобы не разбить) и сохраняют в вате, смоченной 3% раствором борной кислоты. Очень удобны протезы из пластмассы. Протезы даже с незначительными дефектами употреблять нельзя.

#### **РАНЕНИЕ ГЛАЗА ПРОБОДНОЕ (VULNUS OCULI PERFORANS).**

**Симптомы и течение.** Боли, часто падение зрения, наличие раневого отверстия, в которое могут выпасть оболочки глаза; при прободном ранении в области склеры рана темного цвета. Глаз наощупь мягкий.

Последствия — возможность попадания инфекции в глаз (пан-офтальмит) (см.), а также опасность перехода воспаления на второй глаз (симпатическое воспаление глаз) (см.).

**Лечение.** В конъюнктивальный мешок закапывают дезинфицирующие капли (Sol. Albucidi 30%, Sol. Collargoli 3%, Sol. Chinini hydrochlorici 1%, приготовленный без прибавления кислоты). Если инородное тело соприкасалось с землей, надо ввести внутримышечно 1 500 единиц противостолбнячной сыворотки (лучше дробными дозами по Безредке) (см.), затем наложить на глаз стерильную повязку и срочно направить больного к специалисту. При начинающейся инфекции (гнойная инфильтрация раны, гной в конъюнктивальном мешке) внутрь назначают белый стрептоцид 0,3 четыре-шесть раз в день или сульфидин по 0,5—1,0 четыре-пять раз в день; пенициллин по 20 000—30 000 единиц внутримышечно каждые 4 часа без перерыва на ночь (2—3 дня). В конъюнктивальный мешок каждые три часа засыпать порошок альбукцида или Ung. Streptocidi albi 2%, или Ung. Sulfidini 2%.

**СИМПАТИЧЕСКАЯ ОФТАЛМИЯ, СИМПАТИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗ (OPHTHALMIA SYMPATICA).** Болезнь обычно является последствием прободного ранения глаза, особенно ранения в области ресничного тела, если в результате этого ранения развился вяло текущий иридоциклит, т. е. воспаление радужной оболочки и ресничного тела (см.).

Симпатическое воспаление возникает обычно на здоровом глазу через 3—8 недель со дня прободного ранения первого глаза, но может развиваться и через несколько лет. Легко раздражающиеся, болезненные при дотрагивании глаза, ослепшие в результате прободного ранения, рекомендуются удалять.

**Симптомы и течение.** Раздражение, светобоязнь второго, здорового, до этого глаза. Боли при давлении на глаз, перикорнеальная (околороговичная) гиперемия конъюнктивы, воспаление радужной оболочки (ел\*), изменение цвета последней, узкий зрачок. Зрение постепенно падает.

**Профилактика** — своевременное, до развития симпатического воспаления, удаление раненого глаза, если в течение 10—15 дней иридоциклит не проходит.

**Лечение.** Удалить раненый глаз, если он безнадежно слеп. Второй глаз лечить, как лечат воспаление радужной оболочки (см.). Общее лечение: 40% раствор уротропина внутривенно, втирание

серой ртутной мази (по 3,0 тщательно втирает ежедневно сам больной в разные участки кожи в течение 5—6 дней, после чего принимает гигиеническую ванну; на курс— 30 втираний, при втираниях — полоскать рот 2% раствором бертолетовой соли).

Срочно направить больного к специалисту!

**ТРАХОМА (TRACHOMA, CONJUNCTIVITIS TRACHOMATOSA). ХРОНИЧЕСКОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КОНЬЮНКТИВЫ.** Симптомы и течение. Инфильтрация конъюнктивы, развитие сосочков и зерен (фолликулов), которые замещаются рубцовой тканью. Трахома длится годами. Различают четыре стадии в ее развитии. Первая стадия (trachoma I) — гипертрофия конъюнктивы, обильное образование зерен, главным образом на верхней переходной складке и обязательно в конъюнктиве хряща, гипертрофия сосочков. Вторая стадия (trachoma II) — начало образования рубцов, которых меньше, чем зерен. Глубокая инфильтрация конъюнктивы, фолликулы держатся. Третий период (trachoma III) — преобладание рубцов, но зерна и глубокая инфильтрация еще имеются. Четвертая стадия (trachoma IV) — законченное рубцевание без признаков инфильтрации и зерен.

**Осложнения** трахомы — воспаление роговой оболочки — паннус (pannus) — сосудистое разлитое поверхностное воспаление роговицы. Может возникнуть язва роговицы, после чего остается непрозрачный рубец (бельмо).

Последствия трахомы. Неправильный рост ресниц (trichiasis), заворот век (entropion). Высыхание соединительной оболочки и роговицы — ксероз, который обычно ведет к слепоте вследствие стойкого помутнения роговицы.

**Исход трахомы.** Образование рубцов. Если была язва роговицы, остается бельмо.

**Лечение.** Выдавливание трахомных зерен один раз в 3—4 недели, массаж "соединительной оболочки вывернутых век ватным тампоном, смоченным в растворе сулемы (1 : 2 000). Массаж можно также делать с Ung. Sulfidini 2% или Ung. Streptocidi albi 2%, или с альбумидом (порошок, мазь 30%, раствор 30%). В последнее время широко применяется после выдавливания трахомных зерен массаж конъюнктивы 1% или 10% синтомициновой эмульсией. Смазывание вывернутых век карандашом Cuprum sulfuricum (синий камень). В позднем рубцовом периоде смазывание карандашом Alumen (белый камень). Промывание глаз Sol. Hydrargiri cyanati или охлусанати (1 : 6 000) 2—3 раза в день. На руки больному дают Sol. Cupri sulfurici 0,5% два раза в день по 2 капли или Sol. Collargoli 3—5%, или Ung. Cupri citrici 3—5%. Рекомендуются местно сульфаниламидные препараты. Трихиаз и заворот требуют оперативного лечения. При язвах роговицы направить к окулисту.

**Профилактика.** Санитарно-просветительная работа, поголовный осмотр населения, особенно коллективов (школы, предприятия, детские учреждения), изоляция заболевших, у которых имеется отделяемое из глаз (гноятся глаза). Выявление источника инфекции (обследование членов семьи заболевшего). Строгое соблюдение правил общей и личной гигиены.

**ФЛЕГМОНА ОРБИТЫ (PHLEGMONA ORBITAE).** Причины. Переход воспаления с век, придаточных полостей, метастаз из гнойного очага при инфекционных заболеваниях.

**Симптомы и течение.** Сильные боли в глазу и голове, озноб, повышение температуры; отек и гиперемия век; сильный отек конъюнктивы. Выпячивание глазного яблока (экзофтальм), ограничение подвижности или даже полная неподвижность глаза.

**Лечение.** Заболевание может угрожать жизни больного. Лечение стационарное под наблюдением врача-окулиста. Местно — тепло (припарки, синий свет, лампа соллюкс), позднее разрез в месте наибольшей флюктуации или по орбитальному краю сверху снаружи.

Внутрь стрептоцид, сульфидин по 0,5—1,0 через 4 часа; внутримышечно пенициллин по 20 000—40 000 единиц через 3 часа (8 раз в сутки) без перерыва на ночь или по 100 000 единиц 2 раза в сутки в 1% растворе пирамидона (см.).

**ЯЗВА РОГОВИЦЫ (ULCUS CORNEAE, ULCUS CORNEAE CATARRHALIS).** Неглубокие язвы серповидной формы образуются у лимба (роговичной каймы); обычно бывают при конъюнктивитах, а в других местах — при туберкулезе, малярии, лихорадочных заболеваниях, как осложнение ранений роговицы.

**Симптомы и течение.** Боли, светобоязнь, слезотечение. Перикорнеальная (околороговичная) гиперемия конъюнктивы. Дефект в ткани роговицы с чистым или гнойным дном. Радужная оболочка раздражена.

**Лечение** должно быть направлено против основной причины (конъюнктивит, туберкулез, малярия и т. п.). Местно — горячие припарки (мешочек из льняного семени, бутылочка, наполненная горячей водой, и т. п.). Если пет конъюнктивита (гнойного отделяемого), повязка на глаз. Вкапывать в глаз раствор пенициллина (100 000 единиц в 10 мл физиологического раствора) каждые 2—3 часа, 20% раствор альбуцида 3—4 раза в день, закладывать 2% сульф-фидиновую мазь. При раздражении радужки — Sol. Atropini sulfurici 1% 1—2 раза в день по 1—2 капли; при болях — Chinini hydrochlorici и Morphinii hydrochlorici aa 0,1, Aq. destill. 10,0 в подогретом виде несколько раз по 1—2 капли в конъюнктивальный мешок. Язву смазывать (после предварительной анестезии). Т-гае Jodi 5%, Sol. Zinci sulfurici 20%, Sol. Brilliantgrun 1%. (См. также *Язва роговицы ползучая*.)

Бельмо на месте язвы лечат Ung. Hydrargyri oxydati flavi 1%, закладывать за веки на ночь, Sol. Dionini 2—7% два раза в день, начиная с меньшей концентрации (концентрацию дионина надо постепенно повышать, так как больной к нему привыкает).

**ЯЗВА РОГОВИЦЫ ПОЛЗУЧАЯ (ULCUS CORNEAE SERPENS).** Вызывается обычно пневмококком, который часто попадает из гнойно воспаленного слезного мешка.

**Симптомы и течение.** Боли, светобоязнь, понижение зрения, небольшой отек кожи век, перикорнеальная (околороговичная) гиперемия. Дефект в ткани роговицы с серовато-грязным дном. Один край язвы плоский, а другой инфильтрирован (желтовато-серого цвета), с подрытым краем; в эту сторону язва прогрессирует.

сируст. Радужная оболочка воспалена (*см.*), на дне передней камеры полоска стерильного гноя — гипопион. Может наступить прободение роговицы, по заживлении которого образуется спаянно с радужной оболочкой бельмо роговицы (*leucoma corneae adhaerens*).

**Лечение.** При воспалении слезного мешка (*см.*) направить больного к специалисту для санации слезоотводящих путей (операция соустья между слезным мешком и слизистой носа, удаление слезного мешка и т. п.). На язву благоприятно действуют капли: пенициллин 100 000 единиц в 10 мл физиологического раствора по 2—3 капли каждые 1—3 часа; раствор менять через 3—4 дня. Хорошее действие оказывают препараты сульфидина (*Ung. Sul-fidini* 2—3%), 30% раствор альбуниды, а также *Sol. Chinini hydrochloric* 1%, приготовленный без кислоты. Употреблять в подогретом виде. При воспалении радужки (*см.*) — 1% раствор атропина 1—3 раза в день до расширения зрачка; в случае угрозы прободения язвы — 1% пилокарпин или *Sol. Eserini salicylici* 0,25%, или *Sol. Proscirini* 0,2% два-три раза в день. Припарки, тепло. Остающееся помутнение роговицы (бельмо) лечат обычным способом (*см.*).

Дно язвы, особенно ее подрывтый (прогрессирующий) край, смазывают *T-rae Jodi* 5%, *Sol. Brihiantgriin* (в 70° спирту) 1%, *Sol. Zinci sulfurici* 20% (щадить здоровую ткань!)

**ЯЧМЕНЬ (HORDEOLUM).** **Причины.** Попадание инфекции (обычно золотистого стафилококка) в сальную железу края века.

**Симптомы и течение.** Ощущение присутствия инородного тела, боли в области века. Ограниченная гиперемия и припухлость по краю или в толще века; болезненность при ощупывании в месте припухлости. Позднее появление желтоватой головки на вершине припухлости, вскрытие и опорожнение гноя. Иногда ячмень не вскрывается и остается в виде уплотнения — градина (*см.*).

**Лечение.** Тепло (припарки, синий свет). Не выдавливать гной! (Опасно в смысле попадания инфекции в вены глазницы и далее в *sinus cavernosus*.) Внутрь — стрептоцид, сульфидин по 0 5—1,0 четыре раза в день. Если остается уплотнение — пеницил-липновая мазь на веки, массаж века с *Ung. Hydraigyri oxjdati flavi* 1% на ночь. Если уплотнение не рассасывается, — оперативное вмешательство.

## ГЛАВА XI

### КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

**АДЕНОМА (ADENOMA).** Множественные опухоли величиной от зерна чечевицы до грецкого ореха. Располагаются на голове, спине, половых органах, иногда симметрично на лице, в окружности носогубных складок и на подбородке, величиной от просяного зерна до горошины.

**Лечение** хирургическое; вымораживание снегом угольной кислоты; электрокоагуляция производится в стационаре.

**АТРОФИЯ КОЖИ (ATROPHIA CUTIS).** **Симптомы.** Встречается в двух формах: 1) первичная диффузная прогрессивная в виде инфильтрата и красноты, которые распространяются постепенно по периферии и приводят к истончению кожи, на которой отчетливо выступают расширенные сосуды; 2) ограниченная пятнистая, при которой ограниченные участки кожи представляются истонченными, мягкими, слегка выпячивающимися.

**Лечение** первичной диффузной атрофии успеха не дает. В некоторых случаях при применении общеукрепляющих средств удается остановить процесс.

Вообще лечение заболеваний сводится к уходу за кожей, назначению различных ванн и смягчительных мазей (*Ung. enroll: ens*, *Ung. Acidi salicylici* 2—3%).

**БАЛАНИТ, БАЛАНОПОСТИТ (BALANITIS, BALANOPOSTITIS).** Воспаление головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти. Наблюдается в результате нечистоплотности и нарушения правил личной гигиены.

**Симптомы и течение.** Покраснение кожи головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти, мацерация эпителия и образование поверхностных эрозий. Обильное гнойное отделяемое с резким неприятным запахом. Зуд, легкая болезненность. Нередко баланит наблюдается в сочетании с фимозом.

**Лечение.** Обмывание, смазывание 2% раствором ляписа с последующим припудриванием висмутом (*Bismuti subnitrici-B Talcii aa* 10,0) или белым стрептоцидом. При наличии фимоза — диэкция (рассечение) или циркумцизия (обрезание).

**БОЛЕЗНЬ ДЮРИНГА (DERMATITIS HERPETIFORMIS DUHRING).** **Симптомы и течение.** Высыпание располагается группами или отдельно в виде волдырей, пузырьков или пузырей на различных частях кожи и нередко на слизистой полости рта (щеки, небо, язык, миндалины, глотка), не поражая волосистой части головы, кожи ладоней и подошвы. Субъективные ощущения: зуд, иногда



Длительное, более резко выраженное при высыпаниях на слизистой полости рта. Течение острое или хроническое. Болезнь часто рецидивирует, длится годами и в тяжелых случаях может закончиться смертью.

**Лечение.** Пузыри асептически прокалывают и применяют индифферентные мази (Ung. Dermatoli 10% или Ung. Xeroformii 10%). В отдельных случаях назначают примочки из Argenti nitrici 0,25%, риванола или марганцовокислого калия (1:1 000). Против зуда применяют мазь (Mentholi 0,6+ Pasta Zinci 20,0) или присыпки (Talc + Amyli aa 10,0).

Внутрь назначают стрептоцид или сульфидин по 0,5 четырёх-пять раз в день, Riboflavini 0,006 три раза в день, мышьяк, осарсол, при бессоннице — бром, веронал, люминал.

**БОРОДАВКИ (VERRUCAE).** Чрезмерное разрастание сосочков кожи и надкожицы (эпидермиса).

Бородавки обыкновенные. Величина от небольшой горошины до ореха. Бывают единичные и нередко множественные. Чаще располагаются на кистях (пальцы, тыл кисти), подошвах.

Бородавки старческие. Отмечаются в пожилом возрасте. Роговые наслоения в виде возвышений, округлых или неправильных очертаний, буроватого или темного цвета, величиной с чечевичу, располагающиеся на тыле кистей, в области висков, на спине, груди.

Бородавки юношеские плоские. Маленькие плоские возвышения без изменения цвета кожи, реже с желтоватым оттенком. Располагаются чаще на тыле кистей, реже на лице и других частях тела.

**Лечение.** Электрокоагуляция, смазывание: Ac. salicylici-f-Ac. lactic aa 1,0+Collodii 8,0. Ung. Resorcini 1—3%. Внутрь мышьяк: Pil. asiatica N. 60 по 1 штуке 3—4 раза в день.

**БОРОДАВЧАТЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ** см. *Туберкулез кожи.*

**ВЕСНУШКИ (EPHELIDES).** Мелкие желтобурые пятна, не дающие никаких субъективных ощущений, располагающиеся преимущественно на лице и на открытых частях тела. Появляются обычно весной при первых лучах солнца, а осенью и зимой проходят или частично исчезают.

**Лечение.** На-почь после умывания теплой водой с мылом на кожу накладывают одну из указанных ниже мазей; при отсутствии раздражения в дальнейшем производят легкое втирание; при появлении раздражения употребление мази надо временно прекратить, применив противовоспалительные средства (Ung. leniens, припудривание тальком); после исчезновения воспалительных явлений лечение мазями продолжают.

Rp. Acidi salicylici  
Hydrargyri praecipitati albi  
Resorcini aa 1,5—2,0 Vaselinei  
Lanolini aa 10,0  
MDS. Мазь

Rp. Hydrargyri praecipitati albi  
Bismuti subnitrici Camphorae aa  
2,0—3,0 Lanolini  
Vaselinei aa 10,0  
MDS. Мазь

**ВОЛОСАТОСТЬ (HYPERTRICHOSIS).** Симптомы. Обильный рост волос на родимых пятнах или (у женщин) в области верхней губы и подбородка.

Лечение. Радикальный успех достигается электрокоагуляцией каждого волосяного сосочка. Для временного удаления волос применяют депиляторий! который наносят на кожу тонким слоем на 5—10 минут и смывают после предварительного соскабливания тупым ножом.

Rp. Barii sulfurati 20,0 Zinci  
oxydati Amyli aa 10,0  
MDS. Депиляторий. Смешивается с водой до кашицеобразного состояния

Для обесцвечивания волос применяют перекись водорода или пергидрол в виде мази.

**ВОЛЧАНКА** см. *Туберкулез кожи.*

**ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ (LUPUS ERYTHEMAIODES).** Симптом ы. Вначале появляется гиперемированное пятно округлой формы, покрытое роговыми чешуйками. Вследствие периферического роста и слияния между собой пятна быстро принимают разнообразные очертания. При механическом удалении чешуек можно обнаружить шипики, которые представляют собой отростки чешуек, проникшие в расширенные фолликулы. Излюбленное место поражения — выпуклые части лица (нос, щеки), ушные раковины, губы и реже тыльная поверхность кистей.

Течение хроническое. Заболевание имеет склонность к рецидивам и обострениям. Может длиться много лет.

Лечение. Общеукрепляющие средства. Регулирование деятельности желудочно-кишечного тракта. Лактотерапия (внутримышечные инъекции молока, в количестве от 2 до 10 мл через 2—3 дня). Аутогемотерапия по 5 мл через день. Внутримышечные инъекции биохинола по 2—3 мл через 2—3 дня, всего 40—50 мл на курс, 2—3 курса с перерывом между курсами в 2—3 месяца. Прием внутрь по 0,2 хинина 2 раза в день и местное смазывание 10% настойкой йода (5 дней лечение и 2 дня перерыв); курс лечения IVa—2 месяца. Акрихин внутрь по 0,1 три раза в день всего до 150 таблеток (10 дней прием и 5 дней перерыв). Acidi nicotinici по 0,1 три раза в день в течение 4—5 недель. Местно Ung. Saloli 5—10%; целесообразно применять снег угольной кислоты.

В ряде случаев хороший терапевтический эффект наблюдается при применении тканевой терапии по Румянцеву (подсадка надпочечника или «букет», т. е. яичко и надпочечник).

**ВШИВОСТЬ (PEDICULOSIS).** У человека могут паразитировать три вида вшей: головная, платяная и лобковая (в области во-

лоеистой части лобка, у половых органов, промежности, подмышечных впадин, в усах и бороде, ресницах и т. д.).

Вши вызывают кожный зуд в результате укусов и раздражения кожи, волдыри и как вторичную инфекцию — пиодермию (гноиничковое воспаление кожи).

**Лечение.** От головных вшей: коротко остричь волосы. Если это нежелательно, пропитать волосы смесью керосина пополам с каким-либо маслом (подсолнечным и т. п.) и надеть на ночь повязку, покрытую клеенкой или компрессной бумагой. Утром вымыть голову горячей водой с мылом. Для удаления гнид смочить волосы столовым уксусом или 10% сабадилловой водой, растворяющей хитиновую оболочку гнид. При пиодермии смазать кожу Ung. Ac. salicylici 2—3% или Ung. Hydrargyri praecipitati albi 3—5%.

С успехом применяют препараты К или СК:

а) смазывание волос 20% мазью препарата К с последующим через час мытьем головы;

б) намыливание волос мылом К или СК и мытье головы через час горячей водой;

в) ношение в течение 3 суток завязанной на голове косынки, пропитанной 2% эмульсией из мыла К или СК так, чтобы волосы были полностью покрыты косынкой. По истечении указанного срока косынку снимают и голову моют и вычесывают (для женщин).

От платяных вшей: баня, ванна, частая смена белья. Удаление платяных вшей сводится к тщательной дезинсекции белья и одежды. Широко применяются препараты ДДТ. При наличии пиодермии — см. *Пиодермия*.

От лобковых вшей (площиц): бритье волос, втирание 30% серной, 5% белой ртутной или серой ртутной мази. Втирания проводят два раза в день в течение 1—2 дней.

Bp. Ung. Hydrargyri cinerei 25,0 DS.  
Мазь.

Bp. Ung. Sulfurati 30% 25,0  
DS. Мазь

Bp. Ung. Hydrargyri praecipitati albi 5% 25,0 DS.  
Мазь

Для уничтожения яиц площиц применяют уксус и раствор сулемы по окончании лечения мазями.

Bp. Hydrargyri bichlorati 1,0  
Aceti Vini или Aceti sabadillici 300,0 MDS.  
Наружное

**ДЕРМАТИТ (DERMATITIS). ВОСПАЛЕНИЕ КОЖИ.** Может появиться под влиянием различных внешних физических, химических причин и некоторых медикаментов.

**Симптомы и течение.** В начальной стадии — покраснение и отечность кожи, в дальнейшем — пузырьки или пузыри, ко-

торые, вскрываясь, образуют поверхностные ссадины, мокнутие и корочки. Зуд и жжение.

**Лечение.** Устранить основную причину. Внутрь назначают легкие слабительные: Pulv. rad. Rhei по 0,5 г 3 раза в день, в начальной стадии — индифферентные присыпки или болтушки, в дальнейшем, в зависимости от процесса, — примочки и пасты. Как правило, необходимо применять хлористый кальций, бромистые препараты, валериану, а также тонизирующие препараты для укрепления всего организма, в первую очередь нервной системы.

Rp. Zinci oxydati Takl '•  
Amyli aa 15,0 MDS.  
Присыпка

Bp. Zinci oxydati Talci  
Glycerini  
Aq. destill. aa 15,0  
MDS. Болтушка

Bp. Zinci oxydati  
Amyli aa 15,0  
Vasellini £0,0  
MDS. Мазь

Rp. Sol. argenti nitrici 0,25% 200,0 DS.  
Примочка

Bp. Sol. Besorcini 2% 200,0  
DS. Примочка

**ДНСТИДРОЗ (D18HYDROSIS). ВОДЯНИЦА.** Симптомы и течение. Мелкие пузырьки, сопровождающиеся зудом, располагающиеся на боковых поверхностях пальцев рук и ладонях, а также на пальцах стоп и подошвах. Нередко джидроз наблюдается при грибковых заболеваниях (см. *Эпидермофития*).

**Лечение.** Горячие ванночки со слабым раствором марганцовокислого калия (1 : 5 000—1 : 6 000) или с танншом (Ac. tannici) с последующими компрессами или мазями.

Bp. Liq. Burovi 50,0  
So\*. Acidi borici 3% 150,0 MDS.  
Для компрессов

Bp. Naphtalani 3,0 Lanolini  
20,0 Aq. destill.  
10,0 MDS. Мазь

Bp. Ung. Diachiylon £0,0  
DS. Мазь

**ЗУД КОЖИ (PEURITIS).** Интоксикация (пищевая, лекарственная) или нарушения со стороны общего состояния организма (дна-

бет, запоры, недостаточность деятельности почек, нарушение деятельности некоторых эндокринных желез и пр.).

**Симптомы и течение.** Чувство зуда и расчесы на ограниченных участках кожи или распространенный зуд туловища. Ночью зуд обычно усиливается.

**Лечение.** Лечение основного заболевания. Пищевой и гигиенический режим. При наличии глистов — глистогонное (сантонин и др.)- Внутрь — бромистые препараты и хлористый кальций. Местно — зудоуспокаивающие средства (обтирания, мази, болтушка, см. *Дерматит*). При нарушении функции эндокринных желез — органотерапия (препараты яичников: овариин, овариокрин по 30—40 капель 3 раза в день; препарат щитовидной железы). Внутривенно Sol. Calcium chlorati 10% 5—10 мл через 1—2 дня, всего 10—12 вливаний.

Rp. Mentholi 1,0  
Ac. carbolic 2,0 Spiritus  
Vini 25,0 • Aq. destill.  
100,0 MDS. Для  
обтирания

Rp. Anaesthesini 1,5  
Vasellini  
Lanolini aa 15,0  
MDS. Мазь

Rp. Zinci oxydati  
Talcii Glycerini  
Aq. destill. aa 15,0 MDS.  
Болтушка

ИМПЕТИГО ЗАРАЗНОЕ см. *Пиодермия*.

ИМПЕТИГО ПРОСТОЕ см. *Пиодермия*.

**ИХТИОЗ (ICHTHYOSIS). РЫБЬЯ ЧЕШУЯ.** **Симптомы и течение.** Сухость кожи, утолщение рогового слоя. Потоотделение уменьшено или отсутствует. Локализация симметричная, поражение располагается преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей. Течение хроническое.

**Лечение** симптоматическое с временным успехом. Теплые мыльные ванны и смазывание индифферентными и смягчительными мазями и кремами.

Rp. Ung. Ac. borici 1—3% 50,0 DS.  
Мазь

**КРАПИВНИЦА (URTICARIA).** Возникает при приеме внутрь некоторых медикаментов или пищевых веществ, а также после ожога крапивой, укусов москитов, комаров или клопов. Наблюдается и как проявление аллергии.

а\*

**Симптомы и течение.** Жжение и зуд кожи. Появление волдырей красного цвета, напоминающих ожог крапивой. Иногда волдыри имеют белый цвет и расположены на покрасневшей коже. Волдыри быстро появляются, исчезают и снова появляются на других участках кожи. Течение обычно острое или хроническое.

**Лечение.** Внутрь назначают хлористый кальций (10%) по одной столовой ложке 3—4 раза в день, Urotropini по 0,5 три-четыре раза в день, местно — присыпки (Talcii-fAmyli aa 10,0), обтирание ментоловым спиртом, болтушка (см. *Зуд кожи. Дерматит*).

**ЛИШАИ КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ (LICHEN RUBER PLANUS).** **Симптомы и течение.** Высыпания состоят из плоских блестящих узелков многоугольной формы с точечным вдавлением в центре величиной с булавочную головку. Имеют склонность к слиянию, в результате которого образуются кольцевидные фигуры. Встречаются чаще всего симметрично на конечностях, преимущественно на предплечьях и голенях, а также на туловище и наружных половых органах. Нередко лишай располагается на слизистой полости рта (щеки, губ, пеба и языка). Заболевание сопровождается зудом. Течение длительное: на слизистой при отсутствии лечения лишай может существовать годами. Поражение встречается чаще всего в возрасте 20—55 лет, в детском возрасте — очень редко.

**Лечение.** Специфическим средством является мышьяк (Pil. asiatica по одной штучке 3—4 раза в день; принимают по 120 пилюль); осарсол (метод применения см. *Сифилис, лечение*), рибофлавин (в течение 3—4 недель). Местно назначают присыпки, болтушку (см. *Дерматит*), мазь Унна.

Rp. Hydrargyri bichlorati 0,05—0,1 Acidi  
carbolic 2,0 Ung. Wilsoni 50,6  
MDS. Мазь

Rp. Riboflavin] 0,008  
Glucosi 0,5  
M. f. pulv. D. t. d. N. 30 S. По 1  
порошку 3 раза в день

**ЛИШАИ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ (HERPES ZOSTER).** **Симптомы и течение.** Высыпание состоит из группы пузырьков, которые располагаются на покрасневшей поверхности по ходу нерва. Преимущественная локализация лишая — по ходу межреберных нервов; пузырьки чаще расположены изолированно, но могут и сливаться. Появление пузырьков и их обратное развитие сопровождаются зудом, жжением и местной болезненностью; иногда отмечается общее недомогание и субфебрильная температура.

**Лечение.** Защита от внешних раздражений; припудривание крахмалом, применение цинковой пасты. Ung. Dermaloli или Ung. Xeroformii (5—10%), Pasta Zinci. Внутрь назначают салициловый натрий (0,5 три раза в день), аспирин (0,3 три раза в день), пирамидон (0,3 три раза в день), хинин (0,25 четыре раза в день), стрептоцид

(0,5 три раза в день), внутривенно Sol. Urotropini 40% (5—10 мл через 2—3 дня). При одновременных невралгических болях — облучение кварцевой лампой и лампой соллюкс.

**ЛИШАЙ ОТРУБЕВИДНЫЙ, ИЛИ РАЗНОЦВЕТНЫЙ (PITYRIASIS VERSICOLOR).** Симптомы и течение. Появление на туловище (обычно на груди и в межлопаточной области) отрубевидно шелушащихся желтобурых пятен. В начало заболевания появляются мелкие пятна, которые затем постепенно увеличиваются по периферии и сливаются, в результате чего образуются пятна крупных размеров. В запущенных случаях, поражая обширные пространства кожного покрова, они принимают вид географической карты. Окраска пятен часто напоминает цвет кофе с молоком. Субъективные ощущения отсутствуют. При смазывании настойкой йода пятна принимают более насыщенную окраску по сравнению с окружающей здоровой кожей.

**Лечение.** Смазывание 2—5% настойкой йода 2—3 раза в день или 2% салициловым спиртом (Ac. salicyl. 0,6+ Spiritus Vim 70° E0,0). Хороший эффект наблюдается при применении раствора гипосульфита с последующим втиранием раствора соляной кислоты (см. Чесотка, лечение по методу Демьяновича).

**ЛИШАЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ (HERPES SIMPLEX).** Симптомы и течение. Остро протекающее высыпание (чаще на губах) пузырьков величиной с булавочную головку, обычно с прозрачным, а иногда с мутным или кровянистым содержимым. Пузырьки располагаются обычно группами на гиперемизированном основании. Через 2—3 дня они вскрываются, содержимое их высыхает и образуются красновато-коричневые корочки, которые через 8—10 дней отпадают. Субъективно на месте высыпания отмечается жжение и небольшой зуд. От расположения лишая зависит и его наименование: на губах располагается herpes labialis, s. febrilis, в области носа — herpes nasalis, на половых органах — herpes proenitalis и т. д.

**Лечение.** Внутрь назначают сирептоцид по 0,5 три раза в день, местно — присыпки, болтушки (см. Дерматит), пасты (цинковые и др.), при наличии острых воспалительных явлений — холодные примочки.

Вр. Amyli (seu Dermatoli)  
Talci" Sa 15,0 MDS.  
Присыпка

**ЛИШАЙ РОЗОВЫЙ (PITYRIASIS ROSEA).** Симптомы и течение. Обычно появляются быстро увеличивающиеся в размере розово-красные пятна, расположенные симметрично на боковых поверхностях туловища и сгибательных поверхностях конечностей. Нередко отмечается легкий зуд. Сыпь достигает наибольшего распространения обычно в течение 2 недель. Отдельные пятна имеют овальные очертания, величина их различна, края несколько возвышаются над уровнем кожи; центральная часть западая, покрыта нежными эластичными чешуйками. С течением времени сыпь бледнеет и исчезает. Общая длительность заболевания около 6 недель.

**Лечение.** Припудривание присыпками (Talci-(-Amyli aa 10,0). При наличии зуда — болтушки (см. Дерматит).

**ЛИШАЙ СТРИГУЩИЙ (HERPES TONSURANS S. TRICHOPHYTIA).** Вызывается различными видами грибов из рода трихофитонов. Желательно подтверждение диагноза бактериологически — нахождением грибка в пораженном волосе или соскобе кожи.

**Симптомы и течение.** Различают следующие формы, а) Трихофития гладкой кожи. Встречается чаще у детей и характеризуется появлением на коже шелушащихся пятен розового цвета, на поверхности которых, особенно по краям, высыпают мелкие быстро вскрывающиеся пузырьки, засыхающие в виде корочек. В дальнейшем пятна увеличиваются за счет роста по периферии, а в центре отмечается обратное развитие. Сливаясь, пятна образуют различные фигуры. Субъективные ощущения чаще отсутствуют. Локализация весьма разнообразная, преимущественно на открытых участках кожи (лицо, шея, предплечья, тыл кистей рук), б) Поверхностная трихофития волосистой части. Мелкие шелушащиеся очаги округлой формы, слегка розового цвета, располагающиеся на волосистой части головы, бороды или усов. Волосы на пораженных участках обломаны на 2—3 мм над уровнем кожи и имеют вид черных точек. Очаги поражения медленно увеличиваются за счет периферического роста. Течение хроническое. Наблюдается преимущественно в детском возрасте и к периоду половой зрелости самопроизвольно исчезает, в) Глубокая трихофития кожи. Инфильтрированные бляшки, усеянные по поверхности фолликулярными пустулами. В дальнейшем пустулы вскрываются, гнойное содержимое выделяется и засыхает, образуя зеленоватобурые корки. Бляшки могут достигать довольно крупных размеров по периферии (до величины ладони), г) Глубокая трихофития волосистой части. Ограниченный воспалительный инфильтрат, выступающий над уровнем кожи, вначале плотный, в дальнейшем размягчающийся. Волосы на пораженных участках либо сохранены, либо частично выпадают. Процесс имеет склонность к самоизлечению. Глубокая трихофития часто поражает детей в возрасте до 10 лет. На волосистой части головы у мужчин при расположении в области усов и бороды болезнь носит название паразитарного сикоза — Sycosis parasitaria. д) Трихофития ногтей. Разбухание и утолщение ногтевой пластинки, которая становится рыхлой и ломкой. Процесс начинается со свободного края и может захватить всю ногтевую пластинку; ногтевые валики обычно не поражаются.

**Лечение.** » При трихофитии гладкой кожи назначают смазывания 10% настойкой йода раз в день в течение 5—10 дней или чередуют их со смазываниями мазью Вилькинсона. При трихофитии волосистой части производят удаление волос с последующим местным применением: T-gae Jodi, Ung. Wilkinsoni, Ung. Acidi salicylic (5—10%). \*

Удаление волос проводится рентгеновским облучением с последующим механическим выдергиванием оставшихся волос ресничным пинцетом; через 16—18 дней после облучения волосы выпадают. Можно применить также таллиевый пластырь,

Rp. Empl. Thallii acetici concentrati 10—15—20%  
30,0—5J,Q  
DS. Наружное

**ЛИШАЙ ЧЕШУЙЧАТЫЙ (PSORIASIS VULGARIS).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е . Пятна или папулы, покрытые мелкими, легко соскабливаемыми серебристыми чешуйками. При энергичном поскабливании чешуек ногтем обнажается пленка с блестящей поверхностью. По удалении пленки появляется характерное точечное кровоотечение вследствие повреждения капилляров сосочков кожи. Высыпания обладают склонностью к периферическому росту и сливанию, образуя сплошные поражения кожи и кольцевидные фигуры разнообразной величины. В одних случаях наблюдается лишь несколько очагов, в других — поражаются обширные участки кожного покрова. Излюбленные места высыпаний — разгибательные поверхности верхних и нижних конечностей, особенно кожа локтей и коленных суставов. Нередко сыпь располагается на волосистой части головы, реже — на лице, ушных раковинах, ладонях и подошвах. В случаях распространенного чешуйчатого лишая наблюдается поражение кожи в области поясницы, крестца, мошонки и головки полового члена; довольно часто поражаются ногти. Субъективные ощущения обычно незначительны.

Т е ч е н и е хроническое. В отдельных случаях промежутки без высыпаний могут быть весьма длительными (3—5 и даже 10 лет и более).

Л е ч е н и е . Мышьяк — внутрь или подкожно.

Rp. Sol. Arsenicalis Fowleri  
Aq. Mentae piperitae aa 10,0 S. От 2 до 10  
капель 3 раза в день после еды

Rp. Pil. asiaticae N. 100  
S. От 1 до 3 пилюль 3 раза в день  
(общим числом до 200 штук)

Rp. Natrii arsenicici 0,3  
Sol. Ac. carbolic 0,25% 30,0  
Sterilisetur!  
DS. Для подкожных инъекций, всего 30  
инъекций по 1 мл ежедневно

Внутрь — бромистые препараты или хлористый кальций

Rp. Sol. Natrii bromati 4—5% 200,0 Rp.  
Sol. Calcii chlorati 10% 200,0

DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

пли микродозы брома 0,5—2% с кофеином (М. К. Петрова) по 1  
столовой ложке 3 раза в день

Из физических методов лечения можно рекомендовать общее облучение кварцевой лампой, солнечные ванны, хорошие результаты дает курортное лечение в Сочи — Мацесте, Пятигорске и на других курортах такого же типа. Благоприятный эффект наблюдается в слу-

чае применения псориазина. При применении мазей следует постепенно увеличивать их концентрацию; при раздражении кожи временно назначают присыпки или цинковое масло (Zinci oxydati 15,0+01. Heliantbi 35,0).

Rp. Ung. Chrysarobini 2—10% 50,0 DS.  
Мазь

Rp. Ung. Hydrargyri praecipitati albi 2—10% 50,0 DS. Мазь

Rp. Ung. Ac. salicylici 2—10% 50,0 DS. '-  
Мазь

Rp. Ung. Wilkinsoni 50,0 DS.  
Мазь

В последнее время не без успеха, наряду с перечисленными методами лечения, применяют тканевую терапию (подсадка ткани яичка, надпочечника или одновременно обеих тканей по методу И. С. Румянцева).

**МИКРОСПОРИЯ (MICROSPORIA).** Вызывается грибом, пещероходящим от человека или животных.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е . Появление на гладкой коже немногочисленных круглых пятен розового цвета с явлениями обрватного развития в центре. На волосистой части головы заболевание протекает в виде значительных по размерам очагов шелушения. Волосы па этих очагах оказываются у основания обломанными и окруженными спорами грибка в виде беловатой муфты. ■ •

Л е ч е н и е такое же, как и при трихофитии (см. *Лишай стригущий, лечение*).

**МОЛЛЮСК ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ (MOLLUSCUM CONTAGIOSUM).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е . Плотный полушаровидный узелок величиной от булавочной головки до чечевицы, слегка сплюсненной формы. Цвет узелка почти не отличается от цвета нормальной кожи или имеет слегка опалесцирующий оттенок. В центре можно заметить вдавление с маленьким отверстием. При сдавливании узелка выделяется белое кашицеобразное содержимое. Узелки располагаются изолированно, а иногда сливаются. Излюбленная локализация — лицо, половые органы.

Л е ч е н и е . Выдавливание пинцетом и смазывание настойкой иода. При обильных высыпаниях выскабливание острой ложечкой.

**ОЗНОБЛЕНИЕ (PERNIO).** Обычно появляется в зимнее время у лиц с ослабленным организмом.

С и м п т о м ы и т е ч е н и е . Припухлость и синеватый оттенок кожи, обычно тыла кистей и пальцев рук.

Л е ч е н и е . Общее укрепление организма; облучение кварцевой лампой; переменные ванны (горячие и холодные); протирание камфорным спиртом.

**ОНИХОМИКОЗ (ONYCHOMYCOSIS).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е . Ногтевыеплаиши в одних случаях утолщаются, становятся неровными, тусклыми, приобретают грязносерую и желтую окраску, в других становятся ломкими, хрупкими и крошатся. Забо-

левание чаще начинается со свободного края ногтевой пластинки. Край ногтя делается зазубренным и неровным. Течение длительное. **Л е ч е н и е .** Удаление ногтевой пластинки салицилово-резор-циновой мазью. Мягкие части вокруг ногтевой пластинки защищают полосками марли, пропитанными коллодием; на ногтевую пластинку накладывают мазь на 48 часов; при отсутствии болезненности наложение мази повторяют снова на 48 часов; затем на 24 часа накладывают вазелиновую повязку. В результате 4—8 таких сеансов ногтевая пластинка размягчается и почти безболезненно удаляется (мазь из салициловой и молочной кислоты применяется без защиты мягких тканей). По удалении ногтевой пластинки ногтевое ложе смазывают йодной настойкой, сулемовым спиртом и накладывают повязки из жидкости Люголя.

Rp. Ac. salicylici  
Ac. lactici aa 2,0  
Vasellini 24,0 MDS.  
Мазь

Rp. Resorcini 7,5  
Ac. salicylici 2,5  
Vasellini 5,0 MDS. Мазь

**ОПРЕЛОСТЬ (INTERTRIGO).** Воспаление кожи, развившееся на почве раздражения потом в местах соприкосновения кожных покровов и трения (паховая область, область мошонки, под грудными железами и т. д.).

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Краснота, мацерация эпидермиса, эскадины; при вторичной инфекции — гнойнички.

**Л е ч е н и е .** Присыпки и болтушки см. *Дерматит*.

Rp. Zinci oxydati 15,0  
Ac. borici pulv. 1,5  
01. Helianthi 35,0  
MDS. Наружное

\*

**ПАПУЛО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛИД** см. *Туберкулез кожи*.

**ПАРША (FAVUS).** За последние 10—15 лет в СССР почти не встречается. **С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Появляется желтая точка у основания волос, постепенно увеличивающаяся в размерах, которая образует так называемые паршевые щитки, имеющие блюд-цеобразную форму. Щитки могут сливаться и поражать значительную часть волосистого покрова головы. Волосы на очагах поражения становятся сухими, ломкими, пыльными и легко выдергиваются. Парша может поражать ногти и гладкую кожу. Желательно подтверждение диагноза бактериологически — нахождением грибка в пораженном волосе или соскобе кожи.

**Л е ч е н и е** см. *Лишай стригуций, лечение трихофитии во волосистой части кожи*. Предварительно удаляют наросшие корки с помощью 2—3% салицилового вазелина, который применяется на ночь в виде компресса.

**ПИОДЕРМИЯ (PIODERMIA).** Острое гнойное воспаление кожи. Вызывается стафилококками, стрептококками или другими гноеродными микробами. К пиодермии относятся гнойничковые сыпи, импетиго (заразное и простое) и эктима.

**Импетиго заразное (impetigo contagiosa).** Вызывается стрептококком. Чаще заболевают дети.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Заболевание начинается остро; преимущественно в окружности рта, носу, ушных раковинах появляются пузырьки вначале с серозным содержимым, которое в дальнейшем становится мутным, а иногда кровянистым. Они быстро вскрываются, их дно обнажается, содержимое засыхает и образуется желтоватобурая корка, оставляющая после себя розовое пятно, переходящее во временную пигментацию.

**Л е ч е н и е .** Удаление корок с помощью масляных компрессов с последующим применением мазей: Ung. Hydrargyri praecipitati albi 2—5%, Ung. Dermatoli или Ung. Xeroi'ormii 5—10%. Смазывание 2% спиртовым раствором бриллиантовой зелени, синькой или метилвиолетом (Brilliantgrün 0,6+ Spiritus Vini 70° 30,0). Смазывание тонким слоем 2—5% белой ртутной мази (Ung. Hydrargyri praecipitati albi) с последующей присыпкой белым стрептоцидом. При смене повязки здоровую кожу в окружности протирают 1—2% резорциновым или салициловым спиртом.

Показано применение пенициллиновой мази (Ung. Penicillini).

**Импетиго простое (impetigo vulgaris).** Вызывается преимущественно стафилококком. Наблюдается у детей и взрослых.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Место поражения: лицо, волосистая часть головы, туловище и конечности. Отличается от заразного импетиго наличием гнойных пузырьков, обильное отделяемое которых засыхает с образованием плотных корок коричневого цвета.

**Л е ч е н и е** см. *Импетиго заразное, лечение*.

**Эктима (ecthyma).** Вызывается стафилококками или стрептококками.

**С и м п т о м ы и т е ч е н и е .** Начинается обычно как импетиго, но захватывает более глубокие слои кожи. По удалении корок обнаруживаются изъязвления, заживающие рубцами. Чаще образуется на нижних конечностях, ягодицах.

**Л е ч е н и е .** Внутрь — общеукрепляющие средства (мышьяк, железо, фосфор, витамины А и группы В). Освещение ультрафиолетовыми лучами (кварц), аутогемотерапия (по 5 мл через 2 дня, 7—8 вливаний). Пенициллин внутримышечно до 2—3 млн. единиц. Местно — смазывания анилиновыми красками (см. *Импетиго заразное*). Ванны из раствора марганцовокислого калия 1 : 5 000, примочки из раствора риванола 1 : 1 000 с последующими мазевыми повязками. Ung. Hydrargyri praecipitati albi 5—10%. В последнее время с успехом применяется стафилококковый анатоксин.

**ПЕСЬ (VTILIGO).** Симптомы. Белые пятна различных размеров (лишение пигмента). При локализации на коже волосистой части головы волосы также представляются белыми.

**Л е ч е н и е .** Если нет указаний на сифилис и если лечение эндокринными препаратами не оказывает эффекта, можно применить лучи Букки. В большинстве случаев лечение бессильно.

**ПЛЕШИВОСТЬ (ALOPECIA).**

Причины весьма разнообразны. Большую роль играют нервные потрясения, нарушения эндокринного аппарата, себоррея и др.

**Симптомы и течение.** Вначале отмечается поредение волос (при себоррее). При нервных потрясениях внезапно начинается частичное или полное выпадение всех волос (головы, бороды, усов) при отсутствии изменений со стороны кожного покрова. После инфекционных заболеваний выпадение волос наступает спустя 2—4 недели.

**Лечение.** Установить основную причину и в зависимости от нее назначить соответствующее лечение. Общее укрепляющее лечение независимо от причины (мышьяк, железо, фосфор). Местно мазевая терапия, облучения ультрафиолетовыми лучами (кварц). При себоррее — мытье головы раз в 6—7 дней с последующей мазевой терапией.

Rp. Hydrargyri praecipitati aJbi 0,3  
Sulfuris praecipitati 01. Ricini aa  
3,0 Vaselini 30,0 MDS. Мазь

Rp. Sulfuris praecipitati 1,5  
Resorcini 0,5 Vaselini  
50,0 MDS. Мазь

Rp. Sulfuris praecipitati 3,0 Picis liquidae 1,5 But.  
Cacao (или 01. Ricini) 20,0 Vaselini 10,0  
MDS. Мазь. Втирать в кожу головы за  
1/2—2 часа до мытья

Rp. Resorcini 3,0  
Glycerini 5,0  
Spiritus Vini 100,0  
MDS. Мазь. Втирать в кожу головы

Rp. Resorcini 2,0 01. Ricini 4,0 Spiritus  
Vini 70° 100,0 MDS. Втирать в  
кожу головы

**ПОТЛИВОСТЬ (HYPERTROPHIA).** Усиленная потливость может быть местной (ладони, подошвы, подмышечные впадины) или общей (при туберкулезе, неврастении и пр.).

**Лечение.** При общей потливости надо лечить основное заболевание, при местной — применять ванночки из раствора квасцов, обтирания и присыпки.

Rp. Sol. Formalini 5—10% 150,0  
DS. Для обтирания один раз в сутки

0

Rp. Ac. salicylici 1,0  
Ac. borici pulv. 4,0 Таки  
30,0 MDS. Присыпка

Rp. Ac. salicylici 1-0  
Spiritus Vini 70° 50,0  
MDS. Для обтирания

**ПОТНИЦА (SUDAMINA).** Высыпание мелких пузырьков, наполненных прозрачной или мутноватой жидкостью, вызывающих иногда мучительный зуд.

**Лечение.** Под влиянием гигиенического содержания и припудривания тальком пузырьки быстро исчезают.

Rp. Zinci oxydati Таки ꝑа  
15,0 . MDS.  
Присыпка

**ПОЧЕСУХА (PRURIGO).** Почесуха встречается обычно в детском возрасте, иногда длится в течение 7—8 лет. Характеризуется высыпанием обильного количества мелких красноватых элементов, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, сопровождается сильным зудом.

**Лечение.** Следить за регулярным действием кишечника. Назначить пищу, богатую витаминами (овощи, фрукты, морковь, апельсины, яблоки), ограничить углеводы. Исключить яйца. Ванны из слабых растворов марганцовокислого калия или пшеничных и миндальных отрубей. Освещение ультрафиолетовыми лучами (кварц). Зудотолкающие средства в виде обтираний, мазей, присыпок (см. *Зуд кожи, лечение*).

**ПРОКАЗА (LEPRA).** Вызывается палочкой Ганзена-Ней? сера.

**Симптомы и течение.** Инкубация может продолжаться долгие годы. Различают две формы.

**Кожная форма.** Чаще всего локализуется на лице и ушных раковинах и проявляется в виде пятен желтоватого цвета и узлов. Чувствительность кожи на пораженных участках вначале повышена; позднее наступает анестезия и потеря болевой, температурной и, наконец, осязательной чувствительности. Пятна проказы, располагаясь на лице (между бровями, на лбу, щеках, носу), придают больному особый суровый вид (так называемая «львиная физиономия»). Обычно одновременно с кожными наблюдаются поражения и на слизистых оболочках рта, носа, пищевода и глаз.

**Нервная форма.** При этой форме заболевания поражаются преимущественно периферические нервы и центральная нервная система (контрактуры, язвы и даже отторжение пальцев или крупных частей конечности). Болезнь длится многие годы.

**Лечение.** Обязательное направление в лепрозории в соответствии с имеющимися законами.

**ПУЗЫРЧАТКА (PEMPHIGUS).** Симптомы и течение. Высыпание округлых пузырей величиной от горошины до крупного яйца и больше при отсутствии воспалительных явлений в окружно-

сти. Обыкновенно ладони и подошвы остаются непораженными. Во многих случаях высыпания начинаются на слизистой полости рта (щеки, десны, язык, реже гортань и глотка). Оболочка пузырей в начальной стадии бывает напряженной, позднее становится вялой, подсыхает и превращается в корку. Болезнь может длиться месяцы, годы и в редких случаях заканчивается выздоровлением. Наблюдаются рецидивы. Общее состояние больного зависит от характера заболевания, степени и интенсивности высыпания.

**Лечение.** Общеукрепляющее (мышьяк, большие дозы витамина А и D, рибофлавин по 0,005 г 3 раза в день) и длительное применение сульфидина (по 0,5 г 3 раза в день). Внутривенно — препараты новарсенола. Местное лечение состоит в соблюдении гигиенических правил и назначении ксероформной и дерматоловой 10% мази или 01. Lini+Aq. calcis aa 15,0.

**ПЯТНА РОДИМЫЕ, РОДИНКИ (NAEVUS).** Сосудистые родинки имеют красный или красновато-синеватый цвет, достигают больших размеров, иногда занимая значительную часть лица или другие участки кожи. Пигментные родимые пятна бурой или буро-ваточерной окраски; размеры от небольших до колоссальных; располагаются или на уровне кожи, или имеют вид бородавчатых разрастаний, иногда покрытых волосами.

**Лечение.** Вымораживание снегом угольной кислоты, электрокоагуляция, хирургическое удаление с последующей пересадкой кожи в условиях стационара.

**РАК КОЖНЫЙ (EPITHELIOMA).** Различают следующие формы: Поверхностный, или плоский (базо-целлюлярный), рак кожи. Плотные, изолированные или сгруппированные узелки беловатого цвета с перламутровым блеском. Узелки располагаются на здоровой коже или слизистых оболочках. Субъективные ощущения отсутствуют. Наиболее частое расположение — нос, область висков и скул, окружность глазной щели. С течением времени, обычно после травмы, образуется кровоточащая язвочка, покрывающаяся корочкой, по периферии которой имеется плотный ободок белесоватого цвета. Течение хроническое.

Глубокий (спино-целлюлярный) рак. Отличается от Зазоцеллюлярного более быстрым и злокачественным течением. Встречается чаще у пожилых людей. Локализация — на слизистой оболочке языка, на дне полости рта, весьма часто на губах, у заднего прохода и на половых органах. Края язвы бывают плотные, мозолистые, дно покрыто кровянистой коркой. Сравнительно быстрое развитие метастазов в лимфатические железы и кахексия приводят больного к смерти.

**Лечение** в основном хирургическое. При плоском раке применяют вымораживание снегом угольной кислоты, электрокоагуляцию, рентгенотерапию. В дальнейшем больной должен находиться под наблюдением. При глубоком раке требуется хирургическое вмешательство с удалением близлежащих лимфатических узлов. Хороший эффект наблюдается при применении жидкости лауреата Сталинской премии доктора Гордеева. **РЫБЬЯ ЧЕШУЯ** см. *Ихтиоз*.

**СЕБОРРЕЯ (SEBORRHOEA).** Усиленное выделение лшра кожей. Различают жирную и сухую себоррею.

а»

**Симптомы и течение.** Жирная себоррея (seborrhoea oleosa) чаще всего локализуется на лбу, крыльях носа, подбородке, волосистой части головы. Пораженные участки как бы смазаны жидким маслом, волосы жирны и блестящи. Появляется зуд кожи волосистой части головы, затем начинается выпадение волос.

Сухая себоррея (seborrhoea sicca) поражает преимущественно волосистый покров головы, бороду, усы, брови, ресницы. На коже, покрытой волосами, наблюдается наложение сухих чешуек, вследствие чего волосы приобретают вид как бы напудренных. Зуд, выпадение волос.

**Лечение.** Внутрь — Мышьяк, железо, никотиновая кислота (по 0,1 три раза в день), сера (0,5—1,0 три раза в день). Местное лечение см. *Плешивость*.

**СИКОЗ (SYCOSIS SIMPLEX).** Вызываемся стафилококком.

**Симптомы и течение.** Локализуется чаще всего в области бороды и усов, реже в подмышечных впадинах, в области лобка и ресничного края век. Появляется плотноватый воспаленный красный узелок величиной с булавочную головку, в центре которого имеется волос. Узелки располагаются изолированно или группами. На верхушке узелка находится гнойничок, который вскоре вскрывается; содержимое подсыхает, образуя желтоватобурную корочку. Количество отдельных корочек быстро нарастает, и, сливаясь между собой, они образуют сплошные наслоения.

**Лечение.** В острой стадии делают примочки из разведенной боровской жидкости или Sol. Argenti nitrici (0,25%), или Sol. Bivanoli (1:1 000). Иногда, наряду с местной терапией, приходится проводить эпиляцию (вырывание) волос пинцетом. Окружающую кожу протирают 70° этиловым или 2% салициловым спиртом. Смазывание 2% раствором бриллиантовой зелени на 70°спирту. При небольших воспалительных явлениях применяют 2% дерматоловую мазь. В некоторых случаях хороший эффект наблюдается в результате применения аутогенотерапии (по 5 мл через день), поливалентной или стафилококковой вакцины (по 1 мл), пенициллина 4 раза в день через 4 часа по 25 000 единиц (только в течение дня, ночью назначают перерыв) в продолжение 5—6 дней. Всего 500 000 — 600 000 единиц.

**СКЛЕРОДЕРМИЯ (SCLERODERMIA).** Имеется несколько форм заболевания.

1. Общая склеродермия. Характеризуется образованием плотных инфильтратов кожи, чаще верхних частей туловища, которые иногда приводят к затруднению жевания, глотания, речи, дыхания, что может закончиться смертью.

2. Прогрессивная склеродермия. ' Обычно начинается различными нервными расстройствами (судороги, ощущение холода, онемение кистей и лица). В дальнейшем отмечается уплотнение кожи и она приобретает восковой характер. Заболевание протекает медленно и ведет к истощению и смерти.

3. Частичная склеродермия — в виде кругловатых очагов лилового цвета или в виде полос.

**Лечение.** Общеукрепляющие средства (мышьяк, рыбий жир, витамины), препараты щитовидной железы в комбинации с препара-



тами гипопфиза и яичников, препараты салициловой кислоты, ванны, физиотерапия (диатермия, дарсонвализация, ионизация с йодистым калием). Мягчительные мази (Ung. emollientes).

**СКРОФУЛОДЕРМА** см. *Туберкулез кожи*.

**ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ.** Заболевание вызывается туберкулезной палочкой. Проявляется весьма разнообразно: в виде волчанки, скрофулодермы, папуло-некротического туберкулида, бородавчатого и язвенного туберкулеза кожи.

**Волчанка** (lupus vulgaris). Обычно волчанка развивается в детском или юношеском возрасте, реже после 30 лет.

**Симптомы и течение.** Вначале появляются мелкие бугорки красного цвета величиной с булавочную головку, мягкой консистенции. Чаще бугорки располагаются группами, по периферии образуются новые бугорки. Впоследствии бугорки часто изъязвляются, заживают, оставляя нежные рубчики, на которых можно заметить появление новых бугорков. При надавливании стеклом волчаночный узелок (люпома) принимает буроватый цвет (симптом яблочного желе). Надавливание волчаночного узелка пуговчатым зондом вызывает болезненность и кровотечение. С помощью этих двух методов можно отличить волчаночные элементы от бугорковых си-филидов. Местное разрушение ткани при волчанке в отличие от сифилиса происходит медленно. Волчанка локализуется на любом участке кожного покрова или на слизистой полости рта, чаще на лице в области носа. При расположении на кончике и крыльях носа волчанка может деформировать последний («птичий» нос), а при расположении на губах вызвать сужение ротового отверстия или образовать дефекты с обнажением части десен и зубов. Волчанка протекает хронически. Большого волчанкой следует рассматривать и лечить как общетуберкулезного больного.

**Скрофулодерма** (serophuloderma). **Симптомы и течение.** При скрофулодерме в глубоких слоях кожи образуются плотные узлы величиной с лесной орех и более. В дальнейшем кожа на поверхности узлов принимает цианотичный оттенок, спаивается с узлами и образует массивный инфильтрат; центр узлов размягчается и вскрывается наружу обычно множественными отверстиями, из которых выделяется жидкое ссозно-гнойное отделяемое. В дальнейшем отверстия увеличиваются, сливаются с соседними и образуют глубокие язвы, которые медленно заживают рубцами, образуя мостовидные остатки здоровой кожи. Наиболее частая локализация на щеках около уха, на боковой поверхности шеи, в подключичной области и реже на конечностях.

**Папуло-некротический туберкулид.** **Симптомы и течение.** Заболевание характеризуется высыпанием мелких плотных папулезных образований бледнорозового цвета. В дальнейшем в центральной части высыпаний появляется очажок некроза, засыхающий в корочку буроватого цвета, по отпадании которой остается обрывистый, резко очерченный рубчик. Располагается на тыльной поверхности локтевых и коленных суставов и нередко на разгибательной поверхности верхних и нижних конечностей.

**Бородавчатый туберкулез кожи.** **Симптомы и течение.** Места поражения — обычно конечности (пальцы рук, ног). Имеет

вид массивного инфильтрата с бородавчатыми разрастаниями, между которыми отмечаются трещины и изъязвления.

**Язвенный туберкулез кожи.** **Симптомы и течение.** Возникает у больных тяжелым общим туберкулезом. Начинается с плотного бугорка, который быстро распадается и превращается в язвочку. Дно язвенного поражения неровное, зернистое, бледно-красного цвета, покрыто скудным серозно-гнойным отделяемым. Край язвы изъеден, но в окружности воспалительные явления отсутствуют. Располагается на коже и слизистых полости рта (язык, губы, десны, щеки). На слизистых оболочках можно иногда заметить возвышающиеся желтые точки (зерна Треля).

**Лечение.** Общее лечение туберкулеза. При язвенных и вегетирующих формах выскабливание острой логечкой с последующими компрессами из раствора марганцовокислого калия. Для разрушения или удаления туберкулезного поражения применяют мазь с пирогалловой кислотой:

Kp. Ac. pyrogallici 5,0  
Vasellini 50,0 MDS.  
Мазь

Мазь применяют ежедневно в течение 5—8 дней до образования некроза, после чего переходят на индифферентные мази. Применяют также выжигание снегом угольной кислоты. При бородавчатом туберкулезе показана рентгенотерапия.

В настоящее время значительные успехи достигнуты при лечении волчанки витамином D<sub>2</sub>, который применяется внутрь в виде спиртового раствора, содержащего 200 000 единиц витамина D, а 1 мл. Суточная доза 100 000—150 000 единиц для взрослого больного. Лечение продолжается 4—5 месяцев. При заболевании почек применение витамина D, противопоказано.

**ТРИХОФИТИЯ** см. *Лишай стригущий*.

**УГРИ ПРОСТЫЕ** (ACNE VULGARIS). **Симптомы и течение.** Располагаются на лице (лоб, нос, щеки, подбородок), груди, спине. Часто появляются в период полового созревания и к зрелому возрасту проходят даже без лечения. В начальной стадии образуется закупорка сальной железы, появляется припухлость и воспалительная краснота в окружности. В дальнейшем на верхушке появляется гнойничок. Иногда образуются крупные глубокие узлы.

**Лечение.** Общеукрепляющее. Аутогемотерапия (по 5 мл через день) 10—15 инъекций. Освещение ультрафиолетовыми лучами (кварц). Местные паровые ванны с последующим прокалыванием пустулезных высыпаний и выдавливанием черных угрей или (при жирной себорее) умывание горячей водой с последующим втиранием масел. Внутрь поливитамины, сера (Sulfur depurati) по 1,0 3 раза в день во время еды.

Rp. Sulfuris praecipitati 3,0—5,0 Ac.  
salicylici 2,0—5,0 01. Ricini 3,0  
Spiritus Vini 70° 100,0 MDS.  
Наружное

Rp. Sulfuris praecipitati 10,0  
Camphorae tritae 1,0 Mucilaginis  
Gummi arabici 6,0 Aq. Calcis Aq.  
destill. 5a 100,0 MDS. Наружное

**УГРИ БЕЛЫЕ (MILIUM).** Симптомы и течение. Виутрикожные кисты величиной с булавочную головку. Располагаются чаще на лице и реже на половых органах.

Лечение. Хирургическое удаление, электрокоагуляция.

**УГРИ ЧЕРНЫЕ (COMEDO).** Симптомы и течение. Вначале образуются роговые пробки, в дальнейшем невоспалительные беловатые узелки с черной точкой в центре.

Лечение см. Угри.

**ФОЛЛИКУЛИТ (FOLLICULITIS).** Симптомы и течение. Опухолевидные нагнаивающиеся инфильтраты, располагающиеся на боковых поверхностях головы. Инфильтраты вскрываются, образуя свищевые отверстия. Течение хроническое.

Лечение. Вскрытие свищевых ходов и удаление гноя с последующим применением спиртовых компрессов и мазей. Аутогемотерапия. Общее и местное облучение ультрафиолетовыми лучами. В упорных рецидивирующих случаях — рентгенотерапия.

Rp. Ung. Hydrargyri praecipitati albi 2—3% 30,0 DS. Мазь

Rp. Ac. salicylici 0,5  
Ichthyoli 1,5  
Vasclini 40,0 MDS.  
Мазь

Rp. Ac. salicylici 2,0  
Glycerini 100,0  
Spiritus Vini 70° 100,0  
MDS. Для компрессов

**ЧЕСОТКА (SCABIES).** Заболевание вызывается чесоточными клещами.

Симптомы и течение. Зуд, усиливающийся по ночам; высыпания мелких плотных пузырьков с прозрачным содержимым; чесоточные ходы в виде изогнутых линий сероватого цвета длиной 3—5 см. Излюбленные места расположения чесотки — межпальцевые промежутки кистей рук, сгибательная поверхность лучезапястных суставов, локтевые сгибы (реже разгибательная поверхность верхних конечностей в области локтей), область грудных желез, нижняя половина живота, внутренняя поверхность бедер, ягодицы, боковые поверхности туловища и кожа полового члена (у мужчин). У детей нередко высыпания располагается на ладонях и подошвах, а у грудных детей — на лице. Запущенная чесотка осложняется пиодермией. Чесотка передается в условиях соприкосновения здорового с больным, а также через постельное или носильное белье.

Лечение. Мазь Вилькинсона (Ung. Wilkinsoni), серная мазь (Ung. sulfurati 10—20%). Концентрация мази назначается в зависимости от интенсивности поражения, а также возраста (детям 10—15%). Мази интенсивно втирают ежедневно один раз в течение 5—6 дней. Белье не меняется. Затем следует баня (ванна) со сменой белья. Иногда в результате мазевой терапии появляется дерматит, который вскоре проходит при применении цинковой пасты, цинкового масла или присыпок.

Rp. Pasta Zinci 30,0 DS.  
Мазь

Rp. Zinci oxydati 15,0 01.  
Helianthi 35,0 MDS.  
Наружное

Rp. Zinci oxydati  
Talcis aa 15,0  
DS. Присыпка

Лечение чесотки по методу Демьяновича: готовится 60% раствор гипосульфита (Natrii hyposulfurosi 60,0 + Aq. destill. 40,0), и отдельно 6% раствор соляной кислоты (Ac. hydrochlorici puri 6,0 Aq. destill. 94,0). Техника лечения: раствор гипосульфита наливают в тарелку; больной раздевается донага и, смачивая кисти рук первым раствором, энергично натирает каждую область тела по 2 минуты в следующем порядке: 1) левое предплечье и верхняя конечность, 2) правое предплечье и верхняя конечность, 3) туловище, 4) левая нижняя конечность, 5) правая нижняя конечность. Процедура продолжается всего 10 минут. После этого втирание тем же раствором повторяют в той же последовательности, не оставляя свободных мест. Образовавшиеся на теле после первого втирания кристаллы не удаляют. После высыхания тело натирают раствором соляной кислоты (не наливать в тарелку!) в той же последовательности. В каждую область раствор втирают в течение одной минуты; эту процедуру повторяют 3—4 раза. Лечение обоими растворами продолжается 30—40 минут, после чего больной надевает чистое белье; мытье в бане или в ванне разрешается только через 3 дня. В некоторых, особенно запущенных, случаях цикл лечения чесотки через 4—5 дней повторяют.

**ЭКЗЕМА (ECZEMA).** Возникает под влиянием различных раздражений, но лишь у лиц, кожа которых отличается особой чувствительностью.

Роль нервной системы в возникновении и течении ряда заболеваний кожи, особенно экзем, экспериментально изучена М. К. Петровой (ученик и ближайший сотрудник великого русского физиолога И. П. Павлова).

М. К. Петрова показала, что у собак, которые многократно перенесли так называемые сшибки, нервные срывы и экспериментальные невроты, обычно развивались резко выраженные хрониче-

ские кожнодистрофические процессы в виде экзем, облысения и язв, причем эти болезненные процессы обычно исчезали после восстановления нормальной высшей нервной деятельности и вновь развивались при каждом нервном срыве.

**Симптомы и течение.** Первый ранний признак экземы — краснота и отек кожи (эритематозная стадия). Вскоре появляются мелкие пузырьки, которые быстро вскрываются и сливаются между собой. Вскрываясь, пузырьки образуют мокнущие поверхности, причем обнажается мальпигиев слой (мокнущая экзема). При поражениях волосистой части лица, особенно области бороды, усов, на воспаленной поверхности появляются гнойнички, расположенные вокруг волосяных фолликулов (сикозиформная экзема). При слиянии экзематозных пузырьков в более крупные пузырьки, подсыхающие при вскрытии, особенно при присоединении вторичной (кокковой) инфекции, образуются гнойные корки (импетигиозная экзема). Когда корки отпадают, на эритематозном фоне начинается обильное отслоение рогового слоя эпидермиса — шелушение (се-борройная экзема).

Экзема наблюдается на лице, ушных раковинах, по краю век, в области бороды и усов, грудных сосков (у женщин), в области половых органов, бедренных складок и т. д. На ладонях и на внутренних поверхностях пальцев рук она часто протекает при наличии прозрачных пузырьков.

Течение экземы может быть острым, когда через несколько дней или недель процесс подвергается обратному развитию, или хроническим. В последнем случае заболевание может существовать длительное время (годы), временами угасая и вновь обостряясь или же стойко оставаясь без изменений.

**Лечение.** Приступая к лечению экземы, надо прежде всего выяснить причину заболевания и устранить ее. Учитывая, что у многих больных экземой имеются те или иные нарушения со стороны внутренних органов, нервной и эндокринной системы и пр., при лечении этих заболеваний следует широко пользоваться методами общей терапии и профилактики (специфические и неспецифические методы иммунобиологического лечения). Если экзема связана с нарушением общего состояния здоровья (диабет, заболевание желудочно-кишечного тракта), надо лечить основное заболевание. Общее лечение: мышьяк, витамины, 10% хлористый кальций внутрь или внутривенно, бромистые препараты, аутогемотерапия (по 10 мл через 1—2 дня); 10—15-кратное впрыскивание молока (от 2 до 10 мл через день; дозу повышают в зависимости от реакции организма). В хронических случаях, когда медикаментозное лечение не дает эффекта, в качестве подсобного метода назначают ультрафиолетовые лучи или рентгенотерапию. В подострых и хронических случаях показано курортное лечение на серных водах: Сочи — Мацеста, Пятигорск, Цхалтубо и др. Местно, в зависимости от стадии заболевания при мокнутии, — примочки (Sol. Argenti nitrici 0,25%, Sol. Rivanoli 1 : 1 000), которые надо менять каждые 1—2 часа. В эритематозной стадии назначают примочки из Sol. Resorcini 2—3%, присыпки или болтушку (см. *Дерматит*), в стадии обратного развития — мази и пасты.

Rp. Sulfuris praecipitati 3,0  
Resorcini 0,5 Lanolini  
Vasellini aa 15,0  
MDS. Мазь

Rp. Naphto-Naphtolani 3,0—30,0 Pasta  
Zinci 30,0 MDS. Мазь

**ЭКТИМА** см. *Пилодермия*.

**ЭПИДЕРМОФИТИЯ (EPIDERMOPHYTIA).** Возникает в результате поражения различными видами грибов-эпидермофитов.

**Симптомы и течение.** Встречается на местах повышенного выделения пота (стопы, кисти). В лёгких случаях наблюдается незначительная эритема и шелушение (отслоение рогового слоя эпидермиса), при выраженном воспалении — отек эпидермиса и появление глубоко сидящих плотных пузырьков, просвечивающих сквозь роговой слой в виде саговых зерен. При прогрессирующем отеке эпидермиса пузырьки увеличиваются в размере, сливаются друг с другом и, разрываясь, образуют ссадины, окруженные как бы венчиком, обрывками побелевшего мацерированного рогового слоя. Обычно пузырьки высыпают толчкообразно и располагаются на своде подошвы или на внутреннем крае стопы и лодыжки. Нередко поражаются межпальцевые складки. Субъективные ощущения выражаются зудом и жжением; при значительном воспалении отмечается болезненность во время ходьбы. Эпидермофития может поражать и ногти, изменяя их цвет; ногтевая пластинка желтеет, утолщается, становится полосчатой и ломкой. В тяжелых случаях ноготь деформируется.

**Лечение.** При острых воспалительных явлениях — часто сменяемые (через 20—30 минут) примочки из 1—2% резорцина, свиновой воды или буровской жидкости (половина столовой ложки на стакан воды). Ежедневно горячие ванны с марганцовокислым калием (цвет красного вина). После ванны — осушивание кожи и наложение мази.

Rp. Zinci oxydati 15,0  
De. borici pulv. 3,0  
01. Helianthi 35,0  
MDS. Наружное

Два-три раза в неделю перед наложением мази очистившиеся от роговых наслоений участки кожи смазывают 5—10% настойкой йода. После видимого выздоровления во избежание рецидива в течение месяца продолжают смазывать 2% раствором салициловой кислоты в 70° спирту.

Наиболее рациональным способом лечения является отслойка рогового слоя путем наложения (под компрессную бумагу) на 24—48 часов следующей мази.

Ир. Ac. salicylici 12,0 Ac.  
lactici 6,0 Vaselini  
100,0 MDS. Мазь

После наложения мази назначают ванну, после которой удаляют пинцетом роговой слой кожи и накладывают индифферентную мазь.

**ЭРИТЕМА МНОГОФОРМНАЯ ЭКССУДАТИВНАЯ (ERYTHEMA EXUDATIVUM MULTIFORME).** Инфекционное заболевание.

**Симптомы и течение.** Высыпание пятен, узелков и пузырей, выступающих над уровнем кожи и слизистых оболочек. Излюбленное место расположения — тыльные поверхности кистей рук и стоп; иногда поражаются пальцы, локти и колени. Вначале высыпания имеют светлокрасный цвет, но в течение 2—3 дней принимают цианотичный оттенок. Заболевание часто рецидивирует.

**Лечение.** Внутрь назначают салициловый натрий, аспирин, стрептоцид (по 0,5 три-четыре раза в день), внутривенно 40% уротропин (по 5—10 мл через день), местно ■ — болтушку, присыпку, мазь (см. *Дерматит*).

**ЭРИТЕМА УЗЛОВАТАЯ (ERYTHEMA NODOSUM).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Плотные синевато-красные инфильтраты круглово-овальной формы, болезненные при пальпации. В дальнейшем принимают синевато-багровый цвет (в виде кровоизлияния от ушиба). Наиболее частое место расположения — разгибательная поверхность сустава и голени (в редких случаях поражается лицо и другие участки кожного покрова).

Высыпания возникают остро и нередко сопровождаются нарушением общего состояния организма (недомогание, повышение температуры).

**Лечение.** Внутрь — салициловые препараты или уротропин (Natrii salicylici 0,5 или Aspirini 0,5, или Urotropini 0,5 три-четыре раза в день); назначают общее освещение ультрафиолетовыми лучами, местно — 10% ихтиоловую мазь.

**ЭРИТРАЗМА (ERYTHRASMA).** Вызывается грибом.

**Симптомы и течение.** Желтоватые или желтовато-бурые шелушащиеся пятна с неровными краями. Встречаются обычно на внутренней поверхности бедер, в подмышечных впадинах — под грудными железами (у женщин). Течение длительное.

**Лечение.** Мази: Ung. Ac. salicylici или Ung. Resorcini 2—5%. Облучение эритемными дозами ультрафиолетовых лучей. Обтирание 2—3% салициловым спиртом.

**ЯЗВЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ** см. *Туберкулез кожи*.

## t

### ГЛАВА XII

#### ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

**ГОНОРРЕЯ. ТРИППЕР (GONORRHOEA).** Инфекционное заболевание, вызываемое гонококком Нейссера. Передается, как правило, половым путем. Внеполовое заражение может наблюдаться у детей, особенно у девочек. Инкубационный период гонорреи длится обычно 3—5 дней, в отдельных случаях — 1—2 недели.

**Острая гоноррея (urethritis gonorrhoea acuta)\*.** С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Жжение в мочеиспускательном канале. Край отверстия мочеиспускательного канала воспаляется, появляется обильное гнойное выделение и резь при мочеиспускании. В начале заболевания воспаление держится только в передней части мочеиспускательного канала. Если больному предложить помочиться в два стакана, то моча в первом стакане будет мутная, а во втором прозрачная.

При переходе воспалительного процесса на заднюю часть уретры больные жалуются на частые позывы к мочеиспусканию и болезненность по окончании его. В этих случаях выпущенная в два стакана моча будет мутной в обеих порциях.

**Хроническая гоноррея (urethritis gonorrhoea).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Если больной лечился неаккуратно, преждевременно прекратил лечение или не соблюдал предписанного режима, то болезнь переходит в хроническую форму. В этих случаях воспалительные явления незначительны, болевые ощущения мало беспокоят больного, выделения из мочеиспускательного канала скудны. Обострение гоноррейного процесса может наступить под влиянием какого-либо раздражения (полового возбуждения, алкоголя).

**Осложнения гоноррейного уретрита. П р о с т а т и т (prostatitis)** — воспаление предстательной железы. Увеличение предстательной железы, боли, отдающие в промежность, частые ночные мочеиспускания. Иногда в ткани железы образуется гнойник, который самопроизвольно вскрывается в мочеиспускательный канал или прямую кишку.

**Эпидидимит (воспаление придатка яичка) (epididymitis gonorrhoea).** Повышение температуры (до 40°), припухание и резкая болезненность в области придатка яичка. Боль отдает в пах и нижнюю часть живота. Соответствующая половина мошонки увеличивается. Заболевание может быть двусторонним.

**АРТРИТ ГОНОРРЕЙНЫЙ** — воспаление суставов (arthritis gonorrhoea). Припухлость сустава, болезненность в области при-

<sup>1</sup> Описывается гоноррея мужчин, гоноррея женщин см. *Женские болезни*.

крепления сухожилия к костям, боли при движении сустава. Чаше поражается несколько суставов, но нередко и один.

**Лечение гонорреи.** Обильное питье. Полное воздержание от половых сношений и половых возбуждений. Алкоголь и различные пряности воспрещаются. Во избежание заноса инфекции в глаза — частое мытье рук, особенно после мочеиспускания. Рекомендуется ношение суспензория. Все больные острым гонорройным уретритом подлежат лечению пенициллином или одним из сульфаниламидных препаратов (сульфадимезин, сульфатиазол, сульфазол, сульфидин, белый стрептоцид и т. п.).

Лечение пенициллином проводят в виде внутримышечных инъекций: в течение одного дня производится 4—5 инъекций через 3—4 часа по 40 000—50 000 единиц каждая. Общее количество препарата — 200 000 единиц. Особенно показан пенициллин при хронической гоноррее. Препарат назначают в дозе до 500 000—600 000 единиц (по 50 000 единиц через каждые 3 часа). При применении пенициллина рекомендуется сухоядение. Пенициллин может быть назначен в комбинации с сульфаниламидным препаратом. Доза сульфаниламидного препарата — 10 г (по 1 г 4 раза в день).

При лечении гонорреи одними сульфаниламидами одновременно применяют местное лечение уретры в виде ежедневных промываний ее раствором марганцовокислого калия в концентрации 1 : 10 000—1 : 6 000.

Сульфадиазин, сульфазол, сульфадимезин или норсульфазол назначают в количестве 20 г, которые больной принимает в течение 4 дней по 1 г 5 раз в день через каждые 4 часа с расчетом, чтобы ночной перерыв не превышал 7—8 часов.

Белый стрептоцид назначают по 0,5 г на прием 6 раз в сутки в течение 12 дней.

Схема приема сульфидина или сульфазола \*

| Число приемов | Доза     |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               | 1-й день | 2-й день | 3-й день |
| 7             | 1,0      | 0,5      | 0,5      |
| 10            | 1,0      | 0,5      | 0,5      |
| 13            | 0,5      | 0,5      | 0,5      |
| 16            | 0,5      | 0,5      | 0,5      |
| 20            | 0,5      | 0,5      | 0,5      |
| 24            | 0,5      | 0,5      | 0,5      |
| Итого         | 4,0      | 3,0      | 3,0      |

При дозе 15 г следует рекомендовать восходящие дозы: 1-й день 4 г, 2-й—5 г, 3-й—6 г по 1 г 4—5 или 6 раз в день после еды.

При применении сульфаниламидных препаратов воспрещается назначать больному слабительные средства, содержащие серу (сернистая магнезия, лакричный порошок).

Для повышения сопротивляемости организма больного гонорреей, особенно при осложнениях гонорреи, применяют внутримы-

шечные инъекции гонококковой вакцины (120—150 млн. микробных тел), инъекции молока, начиная с 2 мл через день (4—6 инъекций), или аутогемотерапию по 3—5 мл через 2 дня, всего 7—8 инъекций.

При осложнениях гонорреи (простатиты, эпидидимиты, артриты и др.) показано тепловое лечение в виде физиотерапевтических процедур. При осложнениях на слизистой мочеиспускательного канала у мужчин, особенно в хронических случаях, показано бужирование (осторожно вводится металлический буж на 10—15 минут).

Личная профилактика состоит в применении презервативов и промывании мочеиспускательного канала после случайной половой связи слабым раствором марганцовокислого калия. После полового акта можно рекомендовать быстро выпустить мочу и ввести в уретру 1% раствор протаргола.

**Проведение противовенерических мероприятий на профилактических пунктах.**

**Для мужчин.** 1. Выпустить мочу. 2. Тщательно вымыть водой с мылом руки, половой член, мошонку и близлежащие части, а затем после отворачивания крайней плоти протереть головку полового члена ватой, смоченной в растворе сулемы 1 : 1 000. 3. Промыть переднюю уретру под небольшим давлением раствором марганцовокислого калия 1 : 6 000. 4. В течение 5 минут втирать в головку и ствол полового члена, мошонку и крайнюю плоть мазь Мечникова с добавлением 2—3 мл 0,07% раствора сулемы, особенно тщательно втирая ее в места, где имеются ссадины. 5. Раскрыть губки наружного отверстия мочеиспускательного канала, ввести туда немного мази и путем выжимания несколько раз произвести втирание. 6. Оставив кусочек мази, обернуть указанные места парафиновой бумагой и перевязать марлей.

**Для женщин.** После того как выпущена моча и вымыты водой с мылом наружные половые органы, произвести спринцевание влагалища раствором сулемы 1 : 2 000 и глубокое промывание уретры раствором марганцовокислого калия 1 : 6 000. Далее с помощью зеркала Куско протереть 2% раствором ляписа влагалище и влагалищную часть шейки матки; в наружные половые органы, ближайшие части бедер, промежности и область заднего прохода втирать в течение 5 минут мазь Мечникова с добавлением 2—3 мл 0,07% раствора сулемы. Rр. Calomelanos 10,0

Lanolini

\* Vaseliniaa 15,0 S.

Мазь Мечникова

**ЛИМФОГРАНУЛОМАТОЗ ПАХОВЫЙ** см. Четвертая венерическая болезнь.

**МЯГКИЙ ШАНКР (ULCUS MOLLE).** Болезнь вызывается стрептобациллой Петерсен-Дюкрея. Передается почти исключительно половым путем. Инкубационный период длится 1—2 дня. Появляется мягкошанкерная язва.

**Симптомы и течение.** Множественные мягкошанкерные язвы неправильной формы, с зазубренными краями, шерохо-

ватым, бугристым, покрытым грязносалным налетом дном. Отделяемое язв имеет слизисто-гнойный, иногда кровянистый характер. Язвы локализируются преимущественно на наружных и внутренних листках крайней плоти — уздечки у мужчин — у наружного отверстия уретры; у женщин поражается ладьеобразная ямка, малые и большие половые губы, влагалищный вход, задний проход и очень редко шейка матки.

В результате попадания гноя на окружающие ткани — формируются все новые и новые (дочерние) мягкошанкер-ные язвы. Язвы эти болезненны, сопровождаются островоспалительными явлениями, краснотой, отеком окружающих тканей. Некоторые из них отличаются затяжным течением (фагеденические и гангренозные шанкры) и образованием фимоза и парафимоза.

Близлежащие железы при мягком шанкре или совсем не увеличиваются, или, обычно в конце третьей недели, опухают; они болезненны, спаяны между собой и с окружающими тканями. Иногда железы вскрываются и на их месте образуются новые язвы.

Встречается смешанный шанкр (*ulcus mixtum*), когда одновременно существует мягкий и твердый шанкр, — результат смешанной инфекции (мягкий шанкр-(-сифилис); тогда язва имеет и клинические черты твердого шанкра — первичного склероза.

**Лечение.** Опрятное содержание язв; больные получают местные горячие ванночки из слабого раствора марганцовокислого калия продолжительностью 10—15 минут, одновременно язвы прижигают жидкой карболовой кислотой с последующей присыпкой стрептоцидом или ксероформом. По прекращении гнойного отделяемого прижигания отменяют и больных переводят на лечение мазями: йодоформной, 5—10% дерматоловой, ксероформной, 10% висмутовой; при наличии вялых грануляций применяют мазь Микулича. Внутрь назначают белый стрептоцид по 0,5 шесть раз в сутки, всего на курс 30,0—30,0.

Можно применять также сульфидин, сульфазол, норсульфазол — 20,0 по 1 г 3 раза в сутки. При гангренозных и фагеденических язвах внутривенно вводят новарсенол 0,3—0,45<sup>г</sup> внутримышечно — инъекции пенициллина по 50 000 единиц через 3 часа на физиологическом растворе или же по 300 000 единиц два раза в день в 0,5% растворе новокаина и 1% растворе пирамидона в суммарной дозе до 4—5 млн. единиц. При наличии фимоза назначают местные горячие ванночки из раствора марганцовокислого калия и согревающие компрессы и ежедневные промывания прспущпального мешка тем же раствором. При резко выраженной отечности — покой и холодные примочки из гулардовой воды.

На шанкерные бубоны кладут грелки и производят внутривенные инъекции 5—10 мл цельной или лаковой крови. Если эти меры не дают эффекта, бубоны вскрывают и по удалении гноя полость засыпают стрептоцидом или вводят марлевую турунду с риванолом или 10% эмульсией йодоформа.

После заживления мягкошанкерных язв больной должен находиться под наблюдением не менее 6 месяцев, чтобы вовремя выявить имевшее место одновременное заболевание сифилисом (необходимо произвести повторную реакцию Вассермана).

**СИФИЛИС (SYPHILIS).** Хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бледной спирохетой. Заражение обычно происходит половым и в редких случаях внеполовым путем.

**Симптомы и течение.** Болезнь поражает весь организм: кожу, слизистые, внутренние органы, нервную систему. Высыпания на коже без лечения в дальнейшем могут исчезнуть (латентный, или скрытый, сифилис) с тем, чтобы через некоторое время появиться вновь (рецидивный сифилис).

**Первый инкубационный период.** На месте внедрения бледной спирохеты в первые часы и дни никаких изменений не наблюдается; это первый инкубационный, или скрытый, период сифилиса, в среднем длящийся 21 день. Удлинению инкубационного периода может отчасти способствовать применение пенициллина для лечения предшествующих сифилису заболеваний (го-иоррея, воспаление легких, сепсис).

**Первичный период, твердый шанкр (*ulcus durum*).** По окончании инкубационного периода на месте внедрения спирохеты появляется маленькая эрозия (первичный склероз, твердый шанкр) правильной круглой или овальной формы. Дно ее гладкое, поверхность как бы отполирована, блестящая, отделяемое незначительное, серозно-кровянистого характера. Цвет напоминает свежее мясо. В некоторых случаях (при наличии пиококков) эрозия принимает характер язвы, дно поражения становится грязносерым, отделяемое — гнойным. Основным признаком первичного склероза — уплотнение; шанкр безболезнен, размеры его колеблются от величины булавочной головки (микрошанкр) до величины пилтинника (гигантский шанкр). Шанкры большей частью бывают единичными, иногда они сопровождаются значительным отеком. У ослабленных людей и у лиц, страдающих алкоголизмом, шанкры имеют склонность к омертвлению, распаду. Вслед за появлением шанкра опухают регионарные лимфатические железы. Последние множественны, безболезненны, эластичны, плотны, подвижны, не спаяны между собой и окружающей тканью. Твердый шанкр в первые две недели увеличивается в размере, затем 10—12 дней находится без изменения, после чего начинает обратно развиваться и может зажить даже без лечения, оставляя на месте поражения на длительное время значительный инфильтрат.

**Первичный период сифилиса, иначе называемый вторым инкубационным периодом,** включает время от появления шанкра до вторичных высыпаний и в среднем длится 45 дней. В этом периоде опухают все лимфатические железы. Различают первичный серонегативный сифилис в первые 2—3 недели заболевания, когда серологические реакции в крови еще отрицательны, и серопозитивный сифилис, когда серологические реакции становятся положительными.

**Вторичный период** наступает через 66—70 дней от момента заражения. В это время кожные и слизистые покровы покрываются сифилидами пятнистого (розеола), папулезного, пустулезного характера. Папулы бывают сухие, влажные и экссудативные (пустулезные), а во рту, на слизистых половых органов — мокнущие; в складках кожи под влиянием раздражения папулы часто

гипертрофируются (широкие кондиломы). Излюбленная их локализация — задний проход, мошонка, промежность, кожа под грудными железами (у женщин) и т. д. Широкие кондиломы очень заразительны. В этом периоде различают сифилис вторичный свежий при наличии на коже и слизистых высыпаний с полиадениом, а также первичного склероза или же его остатков, и сифилис вторичный рецидивный при наличии на коже скудных высыпаний, групповых папул в виде колец, гирлянд, и отсутствии первичного шанкра. Рецидивный сифилис большей частью наблюдается у нелеченных и плохо леченных больных через 4—6 месяцев и больше от момента заражения. В этом периоде могут быть и глубокие изменения во внутренних органах, сосудах, нервной системе. Вторичный сифилис, особенно свежий (*syphilis II recens*), нередко сопровождается лихорадкой, припуханием селезенки и печени.

Т р е т и ч н ы й п е р и о д наступает через 1—3—4 и больше лет от момента заражения. Третичный сифилис активный (*syphilis III activa*) делится на поверхностный, бугорковый и более глубокий — гуммозный. При этом часто поражаются трубчатые кости (периоститы, оститы, остеомиелиты) и отмечаются другие поражения костей и суставов.

Бугорковый сифилид (*syphilis cutanea tuberculosa*) характеризуется появлением на коже и слизистых плотных безболезненных бугорков, имеющих групповое расположение, величиной с горошину и больше. Бугорки отличаются своим меднокрасным или коричневатым цветом, склонны к группировке и расположению гирляндами, полукругами, кольцами, а также к периферическому росту (*syphilis cutanea tuberculosa sergipinosa*). Нередко бугорки изъязвляются и по заживлении оставляют рубцы (*syphilis cutanea tuberculosa ulcerosa*). В большинстве случаев бугорковый сифилид рассасывается с образованием характерных фестончатых Рубцовых атрофии.

Гуммозный сифилид (*syphilis gummosa*) начинается в виде безболезненной, лишенной островоспалительных явлений подкожной опухоли, иногда доходящей до размера грецкого ореха и куриного яйца. Размягчаясь в центре, узел вскрывается и выделяет сначала похожую на гумми-арабик сукровичную жидкость, а затем гной. Образовавшаяся язва (*ulcus gummosum*) постепенно расширяется и принимает круглую или полушаровидную форму. Кожа, окружающая гумму, спаивается с последней и принимает синевато-красную окраску. Гуммозная язва характеризуется крутыми обрывистыми краями и глубоким дном, покрытым гнойным налетом. Гуммозные язвы кожи обычно локализуются на конечностях, носу, грудной кости. По заживлении они всегда оставляют глубокие рубцы.

Для третичного периода сифилиса особенно характерны мучительные (приступами) ночные боли в костях. Поражается также сосудистая система (аорта), а нередко и паренхиматозные органы, центральная и периферическая нервная система (менингиты, спинная сухотка, прогрессивный паралич и пр.).

Кроме того, во вторичном периоде при плохо леченном или совсем нелеченом сифилисе встречается очаговое (*alopecia areolaris*),

а иногда и диффузное (*alopecia diffusa*) поражение волос, изменение пигмента на шее, чередование гиперпигментированных пятен с депигментированными (*leucoderma syphiliticum*), поражения со стороны ногтей и пр.

Вторичный и третичный скрытый период сифилиса. Сифилис у лиц, перенесших активные проявления вторичного и третичного периода сифилиса (*syphilis latens*).

Врожденный сифилис (*syphilis congenita*). Сифилис передается плоду матерью; отец непосредственно сифилиса плоду не передает. Различают следующие виды врожденного сифилиса: сифилис плода, ранний и поздний врожденный сифилис.

При с и ф и л и с е плода отмечается белое опеченение легких, сифилитическая пузырчатка, сифилитический остеохондрит.

При раннем врожденном сифилисе часто имеет место сифилитический насморк, припухание селезенки, специфические высыпания на коже и слизистых; вокруг рта и на ягодицах нередко имеется диффузное скопление папул.

При позднем врожденном сифилисе отмечаются главным образом третичные изменения, триада Гетчинсона (дистрофия зубов, паренхиматозный кератит и заболевание ушного лабиринта), саблевидные голени — избыточное отложение костной ткани в области гребня большеберцовых костей.

Л е ч е н и е<sup>1</sup>. Специфические противосифилитические средства (препараты органических соединений мышьяка, висмута, ртути, йода), а также пенициллин.

Из отечественных препаратов мышьяка применяются следующие.

1. Н о в а р с е н о л . Выпускается в запаянных ампулах в дозировке от 0,15 до 0,6; вводится внутривенно, для чего порошок растворяют в 5 мл свежестерилизованной и стерилизованной воды. Вливание производят не раньше чем через 2—3 часа после приема пищи. После вливания больной не должен есть в течение 1½—2 часов. Начальная доза новарсенола при отсутствии противопоказаний 0,15—0,3, максимальная разовая доза для женщин — 0,45, для мужчин — 0,6. Вливания надо производить, как правило, из расчета 0,1—0,12 в сутки. Курсовая доза составляет 5,0—5,55. При третичных формах сифилиса суточная доза 0,1—0,12, а курсовая — 4,0.

У ослабленных людей, при состояниях гиповитаминоза, у лиц, страдающих алкоголизмом, туберкулезом и др., суточную дозу новарсенола рекомендуется уменьшить.

2. М и а р с е н о л вводится внутримышечно в наружно-верхний квадрант ягодицы при помощи длинных (5—6 см) игл. Препарат растворяют в 1,5—2 мл дистиллированной и стерилизованной воды. Разовые и курсовые дозировки миарсенола такие же, как и новарсенола. Миарсенол показан при поздних формах сифилиса, при плохой

<sup>1</sup> Лечение изложено согласно официальной инструкции Министерства здравоохранения СССР (см. Инструкции и схемы лечения сифилиса, гонореи и мягкого шанкра под редакцией проф. В. Я. Арутюнова, МОСКВАРР, Медгиз, 1948).

переносимости новарсенола, у детей в заключительных курсах лечения свежего сифилиса, а также в случаях, когда внутривенное вливание технически невыполнимо. При отсутствии новарсенола миарсенол можно также применять и в первом курсе лечения.

3. О с а р с о л. Применяется внутрь при всех проявлениях позднего сифилиса, при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы, а также в последних курсах при вторичном и третичном сифилисе; может быть рекомендован при лечении сифилиса у детей, а также больным, которые не могут часто посещать амбулаторию. После 5 дней применения осарсола делают трехдневный перерыв. Пятидневные циклы лечения с трехдневными перерывами проводят до тех пор, пока больной не получит 40,0 осарсола. Начиная со второго цикла, больной в первый же день получает полную дозу осарсола — 1,0 в день (утром и вечером по 0,5). При недостаточно хорошей переносимости разовые и дневные дозировки должны быть снижены. Осарсол, как и другие препараты мышьяка, надо комбинировать с висмутовыми или ртутными препаратами (см. дальше). Не следует выдавать на руки больному большие количества осарсола (препарат выдается на 5 дней). Детям, как и взрослым, осарсол назначают 2 раза в день, но в соответствующих возрасту дозировках. Противопоказания к применению осарсола такие же, как и для применения новарсенола. Применение осарсола в сочетании с другими препаратами мышьяка (органическими или неорганическими) недопустимо.

В случае наступления осложнений после приема осарсола (желудочно-кишечные расстройства, заболевания печени, головные боли, зуд, эритема, крапивница, появление белка в моче свыше  $0,03\%$ ), а также каких-либо явлений со стороны нервной системы следует прекратить всякое специфическое лечение и назначить терапию, соответствующую развившемуся осложнению. Возобновление лечения возможно не ранее чем через 5—7 дней после полной ликвидации осложнения. В случае повторного развития явлений непереносимости лечение осарсом следует прекратить на длительное время.

4. А р с е н о к с и д ы (соварсен) — противосифилитические препараты; быстрее выводятся из организма, чем новарсенол. Арсеноксиды быстро вводятся внутривенно — в течение 10—20 секунд. Растворы арсеноксидов готовят таким образом, чтобы в 1 мл раствора содержалось 0,01 г препарата. Начальная доза соварсена — 0,045 г, максимальная — 0,07 г. Вливания арсеноксидов производят 2 раза в неделю, всего на курс вводят 0,815 г соварсена. Разовые и суммарные дозы для женщин и мужчин одинаковы. В настоящее время арсеноксиды в СССР не применяются.

Противопоказания к применению органических соединений мышьяка: острые желудочно-кишечные заболевания; язва желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; тяжелые несифилитические заболевания печени; тяжелые несифилитические заболевания центральной нервной системы; распространенные островоспалительные заболевания кожи и пр. Применение новарсенола, соварсена и др. после инфекционных заболеваний допускается по восстановлении общего хорошего самочувствия, при

полном исчезновении всех симптомов и не ранее 5—6 дней после падения температуры. Перед началом курса больной должен быть всесторонне обследован с целью выяснения, нет ли противопоказаний к применению мышьяковых препаратов; перед вливанием рекомендуется также измерять температуру. Во время лечения обязательно исследование мочи, особенно на белок и уробилин, морфологического состава крови. Имеет значение исследование билирубина в крови, так как увеличенное количество его указывает на расстройство функциональной способности печени.

Побочные явления при лечении препаратами мышьяка: нитритоидные кризы, повышение температуры, лихорадка и эритема 9-го дня, сальварсанные дерматиты, эксфолиативный дерматит, желтуха, геморрагический энцефалит (pyrura cerebri) и некоторые другие. Во всех случаях осложнений вливания должны быть прекращены и назначено соответствующее лечение.

Препараты ртути. Для инъекций пользуются как растворимыми, так и нерастворимыми препаратами ртути. Из первой группы наиболее употребительны: цианистая ртуть (Hydrargyrum cyanatum), содержащая 79% ртути, сулема (Hydrargyrum bi-chloratum corrosivum), содержащая 74% ртути, двуиодистая ртуть (Hydrargyrum bijodatum rubrum), содержащая 44% ртути. Сулема вызывает резкую местную болезненность.

Сулема и цианистая ртуть применяются в виде 2% раствора через день по 1 мл; двуиодистая ртуть — в виде 2% раствора по 1 мл ежедневно. При значительной местной болезненности, а также у ослабленных, плохо упитанных больных рекомендуется применять 1% растворы сулемы или цианистой ртути по 1 мл ежедневно. ■

ftp. Hydrargyri cyanati 0,3 Aq.  
destill. 15,0 M.  
Sterilisetur!

DS. Для инъекций в мышцу по 1 мл через день. На курс 20 инъекций

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi 0,3 Aq.  
destill. 15,0 Natrii chlorati purissimi 0,5  
M. Sterilisetur!

BS. Для инъекций в мышцу по 1 мл через день. На курс 20 инъекций

Rp. Hydrargyri bijodati rubri Natrii jodati aa  
0,5 Natrii chlorati chemici puri 0,2 Aq.  
destill. 25,0 M. Sterilisetur! In vitro  
nigro

DS. Для инъекций в мышцу по 1 мл ежедневно. На курс 30 инъекций



При инъекциях следует строго соблюдать правила асептики. После каждой инъекции иглы и шприцы необходимо кипятить. Иглы надо брать достаточной длины (5—7 см), чтобы лекарственное вещество попало в мышцу; при введении растворов в подкожную клетчатку образуются болезненные инфильтраты, которые держатся очень долго. В некоторых случаях, когда требуется быстрое действие, растворимые препараты ртути вводят внутривенно, главным образом в виде 1% раствора цианистой ртути, сначала 0,5 мл, затем 0,75 мл, 1 мл и далее по 1 мл ежедневно (на курс 30—40 инъекций).

Из нерастворимых препаратов ртути применяют преимущественно салициловокислую ртуть, а также каломель.

Rp. Hydrargyri salicylici basici 3,0 Gummi arabici 1,5 Aq. destill. 27,0 M. Sterilisetur!

DS. Для инъекций в мышцу по 1 мл один раз в 5 дней. На курс 12—15 инъекций

Rp. Hydrargyri salicylici basici 3,0 01. Persicorum (01. Helianthi) 27,0 M. Sterilisetur!

DS. Для инъекций в мышцу по 1 мл один раз в 5 дней. На курс 12—15 инъекций

Rp. Calomelanos vaporis parata 1,0 01. Helianthi 9,0 M. Sterilisetur!

DS. Для инъекций в мышцу по 1 мл один раз в 7 дней. На курс 10—12 инъекций

Салициловокислая ртуть содержит около 54% ртути, а каломель — около 80%. Перед наполнением шприца взвесь нерастворимой ртути подогревают в горячей воде и тщательно взбалтывают. Инъекцию делают двухмоментно: сначала вводят внутримышечно иглу в наружно-верхний квадрант ягодицы, а затем, если из иглы не показывается кровь, медленно вводят лекарственное вещество. При появлении капли крови из иглы (признак попадания в кровеносный сосуд) ее извлекают и инъекцию производят в другое место по тому же методу. Попадание взвеси в кровеносный сосуд влечет за собой очень неприятные для больного последствия: закупорка кровеносного сосуда, сопровождающаяся мучительной болезненностью, причем может наступить омертвление тканей. Омертвление тканей может наступить в редких случаях и после растворимых препаратов ртути.

Попадая в вену, масляная взвесь ртути может быть занесена током крови в мельчайшие разветвления легочной артерии и закупорить их. Наступает эмболия легкого с мучительными приступами кашля, болями в боку, чувством стеснения в груди и чувством страха, одышкой и сердцебиением. Обычно указанные симптомы наблюдаются сразу же после неудачно произведенной инъекции; наблюдаются случаи, когда явления эмболии развиваются позднее.

Эмболия вызывает очень тяжелое состояние больного и приковывает его к постели на 3—4 недели, а в исключительных случаях может закончиться смертью.

Ртуть может вводиться в организм и в виде втираний серой ртутной мази.

Втирания применяются при сифилисе внутренних органов и нервной системы, а также если по какой-либо причине невозможно производить инъекции. Втирают мазь очень тщательно, досуха, в течение 30—40 минут. Не следует втирать мазь в волосистые участки кожи.

Проводя лечение ртутью и другими противосифилитическими средствами, следует систематически (один раз в 6—7 дней) исследовать мочу больного. Появление в моче белка, цилиндров, эритроцитов является признаком заболевания почек, которое требует перерыва в лечении.

Наиболее часты осложнения со стороны полости рта: начиная от легкой гиперемии слизистой и кончая гангренозным распадом тканей. В последних случаях отмечается ухудшение общего состояния больного и повышение температуры. Чтобы предупредить эти осложнения, рекомендуется еще до лечения ртутью провести тщательную санацию полости рта. При лечении ртутью больной должен тщательно чистить зубы и после каждого приема пищи полоскать рот слабым раствором соды, раствором борной кислоты, марганцовокислого калия 1: 5 000 или раствором поваренной соли (половина чайной ложки на стакан воды).

**Препараты висмута.** Биохинол представляет собой 8% взвесь иод-хинин-висмута. В 1 мл взвеси содержится 0,024 металлического висмута. Перед употреблением препарат нужно слегка подогреть и тщательно взбалтывать до получения равномерной взвеси. Препарат вводят в верхне-наружный квадрант ягодиц двухмоментным способом из расчета 4 мл биохинола на 3 дня. При третичном сифилисе внутренних органов и сифилисе нервной системы биохинол применяют из расчета 1 мл в сутки. На курс назначают 50 мл препарата (около 1 г металлического висмута).

**Бисмоверол** представляет собой белого цвета взвесь основной висмутовой соли висмутовой кислоты в нейтральном персиковом масле. В 1 мл масляной взвеси содержится 0,05 металлического висмута. Бисмоверол вводят по 1,5 мл 2 раза в неделю. Всего на курс вводят 20 мл взвеси, что составляет 1,0 металлического висмута.

Висмутовые препараты переносятся лучше, чем ртутные; побочные явления при их применении в основном те же, что и при лечении ртутью; однако они дают чаще осложнения со стороны почек (белок, цилиндры, эритроциты, висмутовые клетки). При возникновении висмутовой нефропатии рекомендуется сделать перерыв в лечении на 1—2 недели. При появлении висмутовой каймы на деснах требуется особое внимание к мероприятиям по санации полости рта.

**Препараты иода** применяются внутрь преимущественно при третичных формах сифилиса. При всех формах сифилиса целесообразно применение иода в перерывах между курсами.

Йодистые препараты особенно хорошо действуют при ночных болях в костях. Наиболее употребителен йодистый калий и йодистый натрий. Лечение начинается с малых доз: сначала 3% раствор (3 столовых ложки в день после еды); при хорошей переносимости дозировку постепенно увеличивают, доводя суточную дозу до 8—10 г.

Rp. Kalii jodati 10,0 Aq. destill. 1℥0,0 DS.

По 1 столовой! ложке 3 раза в день  
после еды

Вместо иода можно назначать иодгиперсол. Препарат не вызывает побочных явлений.

Противопоказанием к йодистому лечению служит геморрагический диатез.

**Принципы лечения сифилиса.** При лечении сифилиса основное внимание врача должно быть обращено на макроорганизм, а именно на усиление его защитных сил.

Важное место при лечении сифилиса занимает тактика врача. Тщательный анамнез, собранный у больного, состояние его внутренних органов и нервной системы, глазного дна, анализы крови, мочи и др. могут сыграть огромную роль при назначении метода лечения. Следует придавать первостепенное значение состоянию высшей нервной деятельности. Больной сифилисом уже достаточно травмирован своей болезнью. Следовательно, его нужно так подготовить, чтобы не нанести ему лишней травмы. Необходимо провести с ним индивидуальную беседу, стараться вывести его из угнетенного состояния, всячески внушать ему, что болезнь его вполне излечима, что она при современной терапии (сальварсан, пенициллин) пре красне поддается быстрому обратному развитию и при аккуратном лечении никаких последствий не оставляет. В своих действиях в индивидуальном подходе к больному врач должен исходить из учения И. П. Павлова, памятуя, что медикаменты оказывают действие на весь организм, в котором ведущую, регулирующую роль играет центральная нервная система.

Лечение сифилиса должно быть ранним, насыщенным, продолжительным и состоять из ряда курсов. Примерное лечение должно быть проведено следующим порядком: при первичном серонегативном сифилисе следует проводить три курса интенсивного комбинированного лечения с интервалами в один месяц. Первый курс: новарсенол 5,55, биохинол 50,0, перерыв один месяц; второй курс: миарсенол 5,55, биохинол 50,0, перерыв один месяц; третий курс: новарсенол 5,55, 10% взвесь салициловокислой ртути 12—15 мл или 2% цианистая ртуть 20 мл.

Первичный серопозитивный и свежий вторичный сифилис следует лечить 6 курсами. Руководящими принципами и в этих случаях должна быть интенсивность лечения и смена препаратов. Лечение проводят примерно по следующей схеме.

Первый курс: новарсенол 5,0—5,55, биохинол 50 мл, перерыв один месяц. Второй курс: новарсенол 5,0—5,55, 2% цианистая ртуть 20 мл, перерыв один месяц. Третий курс: миарсенол 5,0—5,55, биохинол

50 мл, перерыв один месяц. Четвертый курс: новарсенол 5,0—5,55, 2% цианистая ртуть 20 мл, перерыв один месяц. Пятый курс: миарсенол 5,0—5,55, биохинол 50 мл, перерыв один месяц. Шестой курс: 2% цианистая ртуть 20 мл в комбинации с осарсолом (30,0—40,0). При вторичном рецидивном сифилисе рекомендуется предпослать первому курсу 3 инъекции висмутного препарата.

Если реакция Вассермана по переходит в отрицательную к началу третьего курса лечения, то такому больному следует провести не 6, а 8 курсов при условии смены препаратов.

При третичных формах сифилиса курсы лечения должны быть менее интенсивными, а количество их должно быть доведено до восьми. Курсовая доза новарсенола — около 4,0; первая доза 0,15—0,3. Примерное чередование курсов: первый, второй и четвертый курс — новарсенол, третий и пятый — миарсенол, шестой и седьмой — осарсол, восьмой — биохинол. При лечении третичных форм сифилиса сначала делают 5—6 инъекций висмута и ртути, а потом уже переходят к применению препаратов мышьяка. Интервалы между курсами могут быть удлинены до 1/2, месяцев в начале лечения и до 2 месяцев между последними курсами.

В случаях клинического или серологического рецидива предшествующее лечение не принимается во внимание. В этих случаях, помимо специфических препаратов, рекомендуется применять также неспецифическую терапию, например, инъекции 10% эмульсии серы — 0,3; 0,5 (в начале, в середине и в конце курса).

**Лечение местных проявлений сифилиса.** При первичном сифилисе рекомендуются присыпки: Calomelanos 2,0, Talcu veneti 8,0; ксероформ; йодоформ. Хорошо помогает рассасыванию склероза серая ртутная мазь или же ртутный пластырь (Emplastrum mercuriale). При мокнущих широких кондиломах в области половых частей применяют присыпки теми же средствами; при наличии мокнущих, эрозивных папул во рту, сифилитической ангины назначают полоскания дезинфицирующими средствами (марганцовокислый калий, перекись водорода, бертолетова соль). Для прижигания эрозий и язв применяют 5—10% раствор азотнокислого серебра или такой же раствор хромовой кислоты; рекомендуется также смазывание 1% раствором бриллиантовой зелени, раствором новарсенола; одновременно следует принимать внутрь аскорбиновую кислоту по 0,1 три раза в день.

**Курортное лечение сифилиса.** При сифилисе внутренних органов и нервной системы, а также при наличии побочных явлений, вызванных тяжелыми металлами (висмутом, ртутью), очень полезны серные ванны (Пятигорск, Серноводск, Мацеста и др.).

**Лечение сифилиса у беременных.** Беременные, болевшие сифилисом, даже снятые с учета, должны подвергаться специфическому лечению в течение всей первой беременности, независимо от времени заболевания и проведенного ранее лечения. Нормально протекающая беременность не является противопоказанием к лечению мышьяковыми препаратами. Беременные должны

лечиться препаратами новарсенола, висмута и ртути, но не арсен-оксидом (см. *Пенициллинолечение беременных*).

Профилактическое лечение сифилиса рекомендуется проводить:

а) Мужчинам, если после возможного заражения прошло не более 15 дней, два курса смешанного лечения.

б) Женщинам, если после возможного заражения прошло не более 15—20 дней, три курса смешанного лечения.

Это лечение мужчинам проводится новарсенолом и препаратами висмута, женщинам первые два курса — новарсенолом и висмутowymi препаратами, третий курс — новарсенолом и препаратами ртути. Лица, не подвергшиеся профилактическому лечению, подлежат наблюдению: мужчины в течение 3 месяцев, женщины — 6 месяцев;

в) Беременным женщинам в обязательном порядке.

Лечение сифилиса у детей. 1. Дети без клипических и серологических симптомов, родившиеся от больных сифилисом матерей, нелеченных или плохо леченных, подлежат немедленному специфическому лечению.

2. Дети без клинических и серологических симптомов, родившиеся от матерей, получавших профилактическое лечение до или во время беременности, подлежат только наблюдению.

3. Дети без клинических или серологических симптомов, родившиеся от матерей, больных сифилисом, хорошо леченных до и во время беременности, подлежат наблюдению.

4. Лечение детей, больных врожденным сифилисом, проводится по хронически перемежающемуся методу.

5. Лечение должно начинаться возможно раньше и проводиться возможно интенсивнее.

6. При лечении детей применяются в соответствующих дозировках те же противосифилитические средства, которыми пользуются при лечении взрослых: новарсенол, миарсенол, осарсол, висмут, ртуть.

7. При лечении детей, больных ранним врожденным сифилисом, проводится 8 курсов лечения с промежутком между первыми курсами в 1—1½ месяца, а между шестым и седьмым, седьмым и восьмым курсом промежуток может быть увеличен до 2 месяцев.

8. Введение новарсенола, миарсенола грудным детям, особенно с пораженным внутренними органами, необходимо начинать после нескольких инъекций ртути или висмута.

9. Помимо возраста, при назначении лечения необходимо учитывать и вес ребенка. Как новарсенол, так и миарсенол вводят детям до года из расчета 0,01—0,03 на 1 кг веса ребенка. Дозировка повышается постепенно: первое вливание 0,01, второе — 0,015, третье — 0,02, четвертое — 0,03 на 1 кг веса; при хорошей переносимости предыдущих вливаний в дальнейшем дозировка остается та же и после четвертого вливания не повышается.

Промежутки между вливаниями равняются 5 дням.

Если у ребенка после вливания повышается температура, появляется рвота или частый стул, доза на следующее вливание не только не повышается, а, смотря по состоянию ребенка, может быть

а) снижена; иногда

приходится увеличивать промежутки между вливаниями. Для детей слабых, с повышенной температурой, с нервным и висцеральным сифилисом первая доза может быть ниже, а именно 0,005 на 1 кг веса, для последующих вливаний дозировка повышается постепенно. Разовая доза для ребенка в возрасте до одного года при последующих вливаниях не должна превышать 0,1—0,15, в зависимости от веса.

Всего за весь курс грудной ребенок до года получает от 1,0 до 1,25 новарсенола. Количество вливаний колеблется от 10 до 12. Для детей в возрасте от одного года до 3 лет самой большой дозой на 1 кг веса является 0,02 (0,01 на первое, 0,015 на второе и 0,02 на третье вливание на 1-, кг веса). На остальные вливания дозировка новарсенола (миарсенола) остается та же, т. е. 0,02 на 1 кг веса. Разовая доза для детей в возрасте от одного года до 3 лет колеблется от 0,05 до 0,2. Всего на курс ребенок до 3 лет получает от 1,5 до 2,0 новарсенола (миарсенола).

Дети в возрасте от 3 до 5 лет получают не более 0,015 на 1 кг веса (для первого вливания 0,01, для второго и последующих 0,015 новарсенола (миарсенола) на 1 кг веса). Разовая доза для этого возраста колеблется от 0,1 до 0,3 новарсенола (миарсенола). На курс дети в возрасте от 3 до 5 лет получают от 2,0 до 3,0 новарсенола (миарсенола).

Для детей в возрасте от 5 до 10 лет разовая доза для первого вливания равняется 0,1 новарсенола (миарсенола; и повышается постепенно до 0,3 на пятое и остальные вливания. Всего на курс дети в этом возрасте получают от 2,5 до 3,0 новарсенола (миарсенола).

Для детей в возрасте от 10 до 15 лет разовая доза может быть доведена до 0,35 и курсовая до 3,5 при хорошем весе и хорошем общем состоянии ребенка.

Новарсенол вводится грудным детям внутривенно в вену головы, локтевые и яремные вены.

Детям в возрасте до одного года при внутривенном вливании новарсенол вводится в слабо концентрированном растворе: не менее чем в 1,5 мл дистиллированной овежестерилизованной воды. Для детей в возрасте после года новарсенол растворяют из расчета 0,1 на 1 мл воды. Миарсенол любой дозы растворяют не более чем в 1 мл воды.

Растворы новарсенола (миарсенола) готовят непосредственно перед вливанием.

В последних курсах для лечения сифилиса у детей следует при-менять осарсол.

Противопоказаниями к применению сальварсанных препаратов у детей в возрасте до 3 лет в основном являются присоединившиеся инфекционные заболевания, острые расстройства желудочно-кишечного тракта (повторная рвота, упорные обильные срыгивания, частый и жидкий стул, особенно с примесью крови). В случаях нерезко выраженных диспепсий применение новарсенола (миарсенола) не дает ухудшения. У детей старших возрастов противопоказания те же, что и у взрослых.

Осложнения у детей в возрасте до 3 лет, вызванные введением сальварсанных препаратов, наблюдаются реже, чем у взрослых, и протекают обычно легко. Эти осложнения сводятся к небольшому

повышению температуры (не выше 38°) и к расстройству со стороны желудочно-кишечного тракта (срыгивания, рвота, диспептический стул). Эти явления исчезают обычно через 2—3 дня и не служат препятствием для дальнейшего лечения. В детском возрасте дерматиты встречаются редко и протекают обычно легко.

10. Биохинол вводят ребенку из расчета 0,1 мл взвеси, бисмо-верол — из расчета 0,05 мл взвеси, 1% раствор цианистой ртути — из расчета 0,1 мл на 1 кг веса ребенка. Висмутовые и ртутные инъекции делают внутримышечно через каждые 2 дня.

Осложнения при применении висмутовых и ртутных препаратов сводятся главным образом к раздражению, реже воспалению почек и к стоматитам у детей старше года. При применении висмутовых препаратов могут появляться висмутовые клетки в моче и висмутовая каемка на деснах.

Втирания серой ртутной мази делают из расчета 0,1 мази на 1 кг веса ребенка. Применение ртутных препаратов противопоказано у детей слабых, с явлениями анемии, с туберкулезной интоксикацией.

Исследование мочи необходимо производить один раз в 5 дней.

И. В первом курсе лечения ребенку следует вводить сальварсан-ные препараты в комбинации с биохинолом, в дальнейшем висмутовые и ртутные препараты чередуются при обязательном введении сальварсанных препаратов в каждом курсе.

12. Лечение детей с явлениями позднего врожденного сифилиса проводится по общим принципам лечения третичного сифилиса в соответствующих возрасту дозировках. Обычно рекомендуется 8 курсов лечения.

#### Снятие с учета больных, закончивших лечение

1. Критерием излечения следует считать: а) качество проведенного лечения; б) данные клинического, рентгенологического обследования (кожа, слизистые, внутренние органы, нервная система и органы чувств); в) данные лабораторного (серологического, желательно ликворологического) исследования.

2. Больные, начавшие лечение в стадии первичного серонегативного сифилиса, снимаются с учета после 3 курсов полноценного лечения и 2 лет наблюдения, в течение которых каждые 3—6 месяцев производится серологический контроль.

3. Больные, начавшие лечение в стадии первичного серопозитивного, вторичного свежего, вторичного рецидивного и вторичного скрытого серопозитивного сифилиса, снимаются с учета после 6 курсов полноценного лечения и 3 последующих лет наблюдения. При вторичном рецидивном сифилисе, в зависимости от сроков перехода серологических реакций в отрицательные, проводят от 6 до 8 курсов лечения.

4. Больные, начавшие лечение в третичном периоде сифилиса или третичном скрытом периоде, снимаются с учета после **8 курсов** лечения и 3 последующих лет наблюдения.

5. Больные, у которых диагноз сифилиса в прошлом твердо установлен, но которые недостаточно лечились, не берутся на учет, если с момента заражения прошло больше 10 лет; во всех остальных случаях такие больные должны после соответствующего лечения находиться под наблюдением диспансеров в течение 3 лет.

6. Больные серорезистентным сифилисом снимаются с учета после 8 курсов полноценного лечения при добавлении неспецифической терапии в последних курсах и последующего наблюдения в течение 5 лет. При снятии с учета подобных больных необходимо рентгенологическое исследование, а также исследование спинномозговой жидкости после окончания срока лечения.

7. Больные врожденным сифилисом (все формы), получившие 8 курсов полноценного лечения с последующим наблюдением в течение 5 лет, снимаются с учета после клинической, серологической и желательно ликворологической и рентгенологической проверки.

8. Больные свежим сифилисом, работающие в детских учреждениях и учреждениях общественного питания, могут быть допущены к работе после проведения полноценного курса лечения и при условии систематического\* лечения в дальнейшем. Это касается работников всех предприятий по изготовлению, хранению и продаже пищевых продуктов, предприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения, сооружений по водоснабжению, фасовочных цехов фармацевтических заводов и аптек, ш-очных кухонь, пунктов сбора грудного молока, а также работников детских лечебных учреждений, домов инвалидов, санаториев и домов отдыха, связанных с непосредственным обслуживанием детей и больных.

Лечение сифилиса фельдшер может проводить только под контролем врача-специалиста; при приеме на работу больного сифилисом, получившего соответствующее специфическое лечение, фельдшер должен согласовать этот вопрос с соответствующим венерологическим учреждением (венерологический диспансер и др.).

#### Применение пенициллина при лечении сифилиса

Пенициллин эффективен при лечении сифилиса. Пенициллин в среднем вводят внутримышечно или подкожно по 40 000 единиц через каждые 3 часа, по 600 000 единиц на 1 кг веса больного, по не менее 3 600 000 единиц на курс.

#### Лечение пенициллином взрослых

1. **Предохранительное лечение.** Проводят один курс лечения пенициллином.

2. **Сифилис первичный серонегативный.** Первый курс лечения проводят пенициллином, вслед за которым делают 7—10-дневный перерыв, и затем приступают к проведению курса комбинированного лечения (по схемам 1948 г.).

**При мечании.** Следует учесть, что при проведении первого комбинированного курса лечения после пенициллинотерапии иоварсенол вводят из расчета 0,1, а биохинол 1 мл в сутки. Во время перерыва между лечением пенициллином

п первом комбинированном курсом больные остаются в стационаре. После проведения половины специфического комбинированного (первого) курса больной может быть выписан на амбулаторное лечение.

3. Сифилис первичный серопозитивный и сифилис вторичный свежий. Вначале проводят курс лечения пенициллином, спустя 7—10 дней после окончания курса пенициллинотерапии проводят курс комбинированного лечения и после месячного перерыва еще два курса комбинированного лечения с обычными промежутками (все курсы проводят по схемам 1948 г.).

4. Сифилис вторичный рецидивный, а) Нелеченный: первый курс лечения проводят пенициллином, затем следует 7—10-дневный перерыв, вслед за которым назначают курс комбинированного лечения, затем перерыв на 1 месяц, второй курс лечения пенициллином, 7—10-дневный перерыв, снова курс комбинированного лечения и перерыв на 1 месяц, после чего два курса комбинированного лечения (по схемам 1948 г.). б) Леченный, включая серорецидивный: вначале проводят курс пенициллинотерапии (100 000 единиц на 1 кг веса, но не менее 4 000 000 единиц на курс), затем следует 7—10-дневный перерыв, вслед за которым назначают курс комбинированного лечения, затем перерыв на 1 месяц, потом второй курс лечения пенициллином в той же дозе, перерыв 7—10 дней, курс комбинированного лечения, перерыв на 1 месяц и еще три курса комбинированного лечения (по схемам 1948 г.).

5. Сифилис третичный активный. Вначале проводят курс лечения пенициллином, затем назначают 7—10-дневный перерыв, после которого следует пять курсов комбинированного лечения (по схемам 1948 г.).

6. Серорезистентный сифилис. Лечение проводят по схемам вторичного рецидивного леченного сифилиса с добавлением методов неспецифической терапии — инъекции серы и другие методы неспецифической терапии (относится ко всем периодам сифилиса).

7. Лечение беременных. Все беременные независимо от ранее полученного лечения должны лечиться интенсивно. Первый курс проводят пенициллином из расчета 100 000 единиц на 1 кг веса, но не менее 4 000 000 единиц на курс лечения. Затем следует перерыв на 7—10 дней, после которого назначают курс комбинированного лечения без пенициллина, перерыв на 1 месяц, затем второй курс комбинированного лечения (по схемам 1948 г.).

Примечание. По окончании беременности последующие курсы лечения проводят (если предшествующее лечение было недостаточным) в зависимости от стадии сифилиса, при которой начато лечение у беременной. Лечение пенициллином детей, больных сифилисом (проводится по новым инструкциям Министерства здравоохранения СССР от 25/VII 1951 г.).

а) Грудным детям в возрасте до 1 года с проявлениями раннего врожденного сифилиса курсовую дозу пенициллина исчисляют от 200 000 до 300 000 единиц на 1 кг веса. Общее количество пенп-

циллина на курс должно составлять не менее 1,5 млн. единиц. Пенциллин вводят шесть раз в сутки по 20 000 единиц на каждую инъекцию с суточной дозой в 120 000 единиц. Начальные дозы (первые 1—2 суток), во избежание реакции обострения, должны состоять из 5000 единиц на каждую инъекцию, не превышая суточную дозу в 30 000 единиц. В дальнейшем дозировку увеличивают на 30 000 единиц на каждые сутки с доведением до 120 000 единиц в сутки. Продолжительность курса составляет в среднем от 12 до 18 дней. После первого курса пенициллинотерапии назначают перерыв на 2 недели. После перерыва проводят второй курс лечения пенициллином в той же дозе, что и первый. По окончании второго курса пенициллинотерапии назначают перерыв на 3 недели, после чего проводят три комбинированных курса? согласно схемам 1948 г. Дальнейшее лечение зависит от течения заболевания.

б) Детям в возрасте от 1 года до 4 лет с проявлениями раннего врожденного сифилиса назначают курсовую дозу пенициллина от 150 000 до 200 000 единиц на 1 кг веса. Общее количество пенициллина на курс лечения составляет не менее 2 млн. единиц. Методика лечения и продолжительность курса пенициллинотерапии те же, что и в грудном возрасте. Через 3 недели после второго курса пенициллинотерапии проводят три-четыре комбинированных курса по схемам 1948 г.

в) Детям с проявлениями позднего врожденного сифилиса старше 4 лет проводят два последовательных курса пенициллинотерапии с двухнедельными промежутками между ними. Курсовая доза пенициллина — 150 000 единиц на 1 кг веса, но не ниже 2,5 млн. единиц на курс, по 40 000 единиц на каждую инъекцию; инъекций делают 6 раз в сутки. После второго курса пенициллинотерапии проводят 5—6 комбинированных курсов лечения по схемам 1948 г., в зависимости от течения болезни и переносимости лечения.

г) Приобретенный сифилис у детей следует лечить по тем же принципам, как и врожденный сифилис, применяя ту же методику и те же соответствующие возрасту разовые и курсовые дозы препарата.

#### Общие замечания по лечению сифилиса

При беременности, туберкулезе, тяжелых заболеваниях центральной нервной системы (эпилепсия и др.), при психической травме, сифилитическом поражении внутренних органов и сосудов во избежание бурной реакции Герксгеймера рекомендуется лечение пенициллином начинать с половинной разовой дозы, постепенно повышая ее.

В случае абсолютной непереносимости обычной специфической терапии лечение пенициллином проводят в количестве от двух до четырех курсов с 3—4-недельным перерывом, в зависимости от стадии сифилиса.

В первом курсе комбинированного лечения сифилиса (пенициллин + сальварсанные препараты и соли тяжелых металлов) у больных заразными формами сифилиса проводят только половину курса в стационарных условиях; остальная часть курса может быть проведена в амбулатории или в диспансере. Венерологические

учреждения, проводящие лечение сифилиса одним пенициллином и пенициллином в комбинации с другими антисифилитическими препаратами, обязаны проводить систематическое наблюдение за взрослыми по крайней мере в течение 5 лет, а за детьми — 10 лет (не снимать с учета!)<sup>х</sup>.

**ТВЕРДЫЙ ШАНКР** см. *Сифилис*.

**4-я ВЕНЕРИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ** (LIMPHOGRANULOMATO-SIS INGULNALIS). Заражение происходит чаще всего половым путем. Инкубационный период длится 1—3 месяца. На территории СССР в последние годы почти не встречается.

**Симптомы и течение.** Заболевание часто сопровождается повышением температуры, головной болью, слабостью, недомоганием, чувством разбитости и другими общими явлениями. Поражение паховых лимфатических узлов, реже области заднего прохода и прямой кишки. Узлы увеличиваются, становятся плотными и безболезненными. С течением времени они размягчаются, вскрываются, образуя свищи. Заболевание протекает длительно; иногда отмечается слоновость половых органов.

**Лечение.** Сульфидин, сульфазол, сульфатиазол в дозе XHO 1,0 четыре-пять раз в течение 10—20 дней, препараты сурьмы (внутривенно и внутримышечно), рентгенотерапия, электрокоагуляция, инъекции антигена Фрея. При незначительном одностороннем поражении паховых лимфатических узлов показано их удаление хирургическим путем. Из неспецифической терапии применяют аутогемотерапию по 5 мл через день и внутримышечные инъекции молока по 3—10 мл через 1—2 дня. В последнее время рекомендуют (Борзов) применять парэптеральное введение пенициллина в количестве до 3—4 млн. единиц на курс.

<sup>х</sup> См. Схемы применения пенициллина при лечении сифилиса, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 27/VI 1949 г., и Резолюцию пленума Ученой комиссии при отделе по борьбе с кожными и венерическими заболеваниями Министерства здравоохранения СССР, утвержденную Министерством здравоохранения СССР 25/VII 1951 г.

## ГЛАВА XIII

### ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА

**АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ПИОРРЕЯ, ПАРОДОНТОЗ, АМФОДОНТОЗ** (PYORRHEA ALVEOLARIS, PARODONTOSIS). **Симптомы и течение.** Воспаление десневого края, дистрофия десны и периодонта, окружающего шейку зуба, и альвеолярного края. Процесс обычно распространяется в направлении от шейки зуба к его верхушке. Большей частью альвеолярная пиоррея протекает медленно, хронически. В результате воспалительных изменений уничтожается круговая связка, затем нижележащий отдел териодонта; окружающая его кость ячеистого отростка рассасывается, превращаясь в грануляционную и соединительную ткань. В связи с отставанием десны от корня вследствие гибели периодонта и рассасывания альвеолярных стенок образуется десневой и костный карман, часто возникает гноетечение. Параллельно разрушению десны, периодонта и альвеолы происходит обнажение шейки, смещение, выдвигание, расшатывание и, наконец, выпадение зуба.

**Распознавание:** 1) изменение цвета и вида десен: синевато-красная окраска, отечность, рыхлость, краевой гингивит; 2) различная степень атрофии стенки альвеолы, устанавливаемая рентгенографически; 3) образование десневых и костных карманов; гноетечение — беловатый или светловатый гной (пиоррея) может быть выдавлен в небольшом количестве, может сам появиться или отсутствовать совершенно; 4) смещение и подвижность зубов.

Заболевание может начаться поражением области одного зуба; постепенно это поражение начинает прогрессировать на месте и захватывать районы расположения других зубов. Хронически развиваясь, пиоррея может менять темпы развития: замедляться, ускоряться, приостанавливаться. Могут появляться улучшения самостоятельного характера или под влиянием лечения.

**Лечение.** Должно быть обращено внимание на лечение общего заболевания (подагры, анемии и т. д.) и общегигиенический режим, в частности, рациональное построение диеты с преобладанием растительной пищи. Местное лечение: 1) механическая чистка — удаление зубного камня, выскабливание грануляций из карманов; 2) химическое воздействие — растворение остатков камня и прижигание карманов кислотами: 60% раствором молочной, 25% раствором трихлоруксусной, 10% раствором хромовой; 3) пиоцид по Лу-комскому или в сочетании с хирургическим лечением — рассечение кармана и удаление путем выскабливания измененных частей кости, грануляций, камня; при глубоких карманах производится рассечение и срезание карманов; 4) внутримышечные инъекции — малые

дозы (0,1—0,5) молока (20—40 инъекций), изо- или гипертонического раствора хлористого натрия и т. п.; 5) механическое укрепление зубов — специальные шины, рациональное протезирование для разгрузки зубов; 6) физиотерапия — ультрафиолетовые лучи, дарсонвализация, массаж, диатермия, УВЧ (ультравысокочастотное поле). Полезна комбинация нескольких методов.

**БОЛЬ ЗАПЛОМБИРОВАННОГО ЗУБА.** Боль запломбированного зуба (*dolor dentis clausi*) бывает обусловлена известными патологическими процессами и состояниями: кариес, пульпит, гангрена, периодонтит. Предшествовавшее появлению боли пломбированию зуба и самый факт наличия пломбы, герметически закрывающей его полость, до известной степени меняет симптоматику заболевания. Этот факт нередко коренным образом отражается на методике оказания первой помощи и лечения в случаях появления боли в запломбированном зубе.

Следует различать боли, появившиеся непосредственно или вскоре после наложения пломбы, и поздние боли, возникшие через месяцы и даже годы после пломбирования.

В первой группе ранних болей следует выделить **реактивные боли**. Этот вид болей отличается от «амостельных», которые могут быть и ранними, и поздними.

Почти все манипуляции, производимые в корневом канале, в той или иной степени травмируют периодонт: ампутация, экстирпация, эвакуация распада пульпы из канала, введение лекарственных веществ, особенно кислот и концентрированного формалина. Следует считать, что после лечения пульпита и периодонтита, сопровождавшихся гангреной пульпы, наложение пломбы, т. е. герметическое закрытие полости зуба, не совпадает с периодом полного выздоровления больного зуба, а предшествует ему. Выздоровление обычно наступает после пломбирования. Поэтому наложение пломбы следует расценивать лишь как последний акт лечебного вмешательства, обеспечивающего последующее окончательное выздоровление и заживление тканей зуба.

После лечения пульпита могут иметь место два процесса: 1) организация пульпарной культи (рубцевание) в результате применения консервирующих (нейтральных) медикаментов или 2) анорганизация остатков пульпы (мумификация) в результате применения формалина и ему подобных препаратов.

Тот и другой исход наступает через несколько часов или дней после ампутации или экстирпации пульпы и последующего пломбирования. В этом периоде могут возникнуть реактивные боли в запломбированном зубе.

Обычно эти боли носят периодонтитный характер: боль на перкуссию (постукивание), боль при смыкании зубов, самостоятельная ноющая локализованная боль. Такого рода реактивная боль имеет тенденцию к самостоятельному уменьшению и полному исчезновению. Временное выключение зуба из артикуляции (смыкания), смазывание десны йодной настойкой, тепловые процедуры, прием болеутоляющих средств (аспирин, пирамидон) — все это способствует успокоению и быстрому устранению реактивных периодонтитных явлений.

Иная оценка должна быть дана болевым явлениям в тех случаях, когда, помимо периодонтитных болей, появляется боль от горячего. Такая боль в депульпированном зубе — признак возникающего или продолжающегося гнилостного распада пульпы и возникновения очагового периодонтита. Поэтому наличие этого симптома, возникшего в ранние или поздние сроки после наложения пломбы, требует немедленного удаления пломбы и вскрытия полости зуба.

При вскрытии полости зуба с явлениями острого периодонтита необходимо соблюсти ряд предосторожностей.

Во-первых, уменьшить болевые ощущения, возникающие во время высверливания в результате сотрясения и давления бором. С этой целью начинают высверливать пломбу бором малого калибра (№ 1, 2), постепенно повышая размер (№ 3, 5, 6). Хорошо пользоваться копьевидным бором, который специально с этой целью затачивают, или копьевидно-заостренным фиссурным бором. Кроме того, во время высверливания пальцами левой руки (большим и указательным) следует удерживать (фиксировать) коронку зуба с тем, чтобы по возможности предохранить зуб от вертикального давления, неизбежного почти во всех случаях высверливания пломбы.

Во-вторых, необходимо принять меры, предохраняющие против возможной мобилизации инфекции, предупреждающие возможность механического проталкивания остатков распавшейся пульпы за верхушку зуба и за границы периодонтальной щели. Это обстоятельство следует особенно учитывать, так как мобилизация инфекции, гнездящейся в зубе, может вызвать тяжелые септические осложнения. Поэтому освобождение пульпарной камеры от содержимого следует производить<sup>^</sup> помощью небольших по калибру экстракторов и боров.

Устье канала следует освободить от распада с помощью нерв-экстрактора через слой антисептической жидкости (антиформин, хлорамин, азотнокислое серебро), не доходя до середины канала.

В первый сеанс не следует проходить канал до верхушки корня. Лишь после суточной антисептической обработки ложа и остатков пульпы (камеры и корневого канала) возможна полная эвакуация содержимого из канала.

При наличии острого периодонтита и боли от горячего в зубах с каналами, запломбированными цементом, показана экстракция зуба.

Характерный болевой симптом дают остаточные, или резидуальные, пульпиты. «Фактически такого рода пульпит представляет продолжающийся воспалительный процесс в сохранившейся после ампутации или экстирпации культе пульпы. Поэтому в таких случаях болевые симптомы в запломбированном зубе соответствуют корневому пульпиту: иррадиирующие самопроизвольные боли, боль при перкуссии. Лечение заключается во вскрытии полости зуба и удалении остатков пульпы.

**ГИНГИВИТ** см. *Стоматит*.

**ЗАПАХ ИЗО РТА** см. *Стоматит, лечение*.

**ЗУБНАЯ БОЛЬ** см. *Периодонтит, пульпит*.

**ЗУБНОЙ КАМЕНЬ (CALCULUS DENTALIS).** Несмотря на индивидуальный уход, у шеек зубов скапливается налет, особенно в

местах, мало доступных для зубной щетки и плохо очищаемых в процессе приема пищи. При застое слюны из нее выпадают известковые соли, и путем ряда изменений мягкий налет превращается в плотное образование — зубной камень. Распределение зубного камня идет в двух направлениях: вокруг коронки и под десной вокруг корня. Излюбленными местами расположения зубного камня является язычье-язычная поверхность нижних передних зубов и щечная поверхность верхних моляров.

Для предотвращения отложения зубного камня необходимо равномерное пользование во время жевания всеми частями зубного ряда, разжевывание твердой пищи и очистка зубов щеткой. Накопившийся камень должен быть удален. Нормально достаточно удалять зубной камень два раза в год. Но у некоторых людей наблюдается повышенная склонность к образованию зубного камня. В этих случаях камень следует удалять несколько раз в год, а иногда систематически несколько раз в месяц. Скопление зубного камня вызывает воспаление десневого края и обуславливает дурной запах изо рта. Углубляясь под десну, зубной камень содействует атрофии десневого и альвеолярного края, разрушает зубную связку, что, в конце концов, ведет к расшатыванию зуба. Камень нужно удалять весьма тщательно, так как при оставлении неудаленных частиц он вновь быстро накапливается. Иногда приходится применять 25—50% раствор молочной кислоты для растворения его мельчайших остатков. После удаления камня десну смазывают йодной настойкой.

**КАРИЕС ЗУБА (CARIES DENTIS).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Различают острый и хронический кариес. Острый кариес сопровождается незначительной депигментацией (меловое пятно) или слабой пигментацией (светлокоричневое пятно); быстро возникает кариозная полость, увеличивая свои размеры как в глубину, так и в ширину. Хронический кариес обычно сопровождается темнокоричневой пигментацией и весьма медленным течением. По локализации процесса различают: апроксимальный кариес — на боковых поверхностях, поражающий борозды на бисфатальных поверхностях, пришеечный, располагающийся у шейки зуба, и циркулярный, опоясывающий коронку.

Субъективно кариес может вначале не сопровождаться какими-либо болевыми ощущениями; однако большей частью ему сопутствуют различные субъективные расстройства, в частности, появление боли под влиянием холода и различных химических раздражителей — сладкого, соленого, кислого. Самопроизвольная боль при кариесе никогда не возникает. Объективно наблюдается кариозное пятно, затем полость.

**Л е ч е н и е.** Кариозное пятно дает основание для местного вмешательства только в тех случаях, когда пораженная им эмаль размягчена и не склонна к отвердеванию при назначении правильного гигиено-диетического режима и после втирания фтора. Показания к местной терапии кариеса возникают при образовании дефекта; но и тут исключение могут представить случаи поверхностного хронического кариеса, не требующие пломбирования, а подлежащие только зашлифовке с последующим втиранием фтора. Во всех слу-

чаях, когда кариес поражает эмалево-дентинную границу и переходит через нее, имеются абсолютные показания к терапии пломбированием. Сущность лечения сводится к удалению (высверливанию) пораженных кариесом частей эмали и дентина и к пломбированию полости.

**НОМА** см. *Стоматит язвенный.*

**ОСТЕОМИЭЛИТ ЧЕЛЮСТИ (OSTEOMYELITIS).** ГЕМАТОГЕННЫЙ **ОСТЕОМИЭЛИТ.** Возникает в результате метастазирования, инфекции из других очагов при различных общих инфекциях (грипп, тифы, скарлатина, дифтерия, корь и др.) и специфических инфекций (туберкулез и сифилис), при наличии инфекционного очага в каком-либо участке тела, после травмы, в особенности у детей.

Контактный остеомиелит. Возникает в результате непосредственного распространения инфекции из очага, находящегося в мягких тканях, окружающих челюсть, в тех случаях, когда между инфекционным очагом и костью возникает непосредственный контакт. Наиболее часто встречающейся формой является подбородочный фурункул, длительное воспаление десен.

Одонтогенный остеомиелит. Возникает в результате проникновения в челюсть инфекции, или гнездящийся в зубе периодонтит.

**Острый остеомиелит. С и м п т о м ы и т е ч е н и е.** Наличие озноба, явлений общей интоксикации, повышенной температуры с размахами в 1° и больше. Вследствие отека около-челюстной клетчатки и начинающейся флегмоны наблюдается болезненное и затрудненное глотание; иногда быстро появляется сведение челюстей — тризм. В полости рта возле пораженных зубов десна отекает; иногда у переходной складки намечается образование поддесневого гнояника. В мягких тканях лица — коллатеральный отек. При ощупывании челюсти обнаруживается припухлость на самой кости. При поражении нижней челюсти в области прикрепления жевательной мышцы нередко возникает быстро нарастающий тризм (сведение челюстей). Боли, острые и режущие, появляются в начальной стадии заболевания.

**Л е ч е н и е.** Создание местных и общих условий, способствующих прекращению процесса и восстановлению разрушенной кости. В качестве местной терапии показан разрез надкостницы, вскрытие флегмоны. В стадии затихания острого процесса производится удаление пораженных и отторгнувшихся зубов. Удаление омертвевших участков кости (секвестра) производится только после полного его отделения. Тепло (компрессы Или грелки), освещение ультрафиолетовыми лучами. В случаях ограниченного остеомиелита при его распространении рекомендуется хирургическое вмешательство: разрез слизистой оболочки и надкостницы в области пораженных зубов у переходной складки; в тех случаях, где обнаружена флегмона или когда предполагается наличие бурно развивающегося септического остеомиелита, абсолютно показан наружный разрез.

Общее лечение заключается в назначении кальция, сульфаниламидов, пенициллина, глюкозы, сердечных средств и пр.

**ПЕРЕЛОМЫ ЧЕЛЮСТИ (FRACTURAE).** Распознавание в большинстве свежих случаев не представляет значительных затрудне-



ний. Смещение отломков челюсти меняет контуры мягких тканей лица. При центральном переломе нижней челюсти отломки смещены к средней линии. Часто один отломок поднимается вверх, благодаря чему зубная дуга приобретает ступенчатый характер. При боковом переломе отломившаяся часть челюсти оттягивается кверху, а оставшаяся большая часть челюстной дуги отходит назад; кроме того, обе части смещаются к средней линии. Если боковой перелом произошел на обеих сторонах челюсти, то челюсть оттягивается кзади и книзу. В противоположном направлении (вперед) челюсть смещается, если двусторонний перелом произошел позади прикрепления жевательных мышц, т. е. если произошел перелом обеих восходящих ветвей и челюсти. При одностороннем переломе восходящей ветви челюсть смещается в обратную сторону. Перелом суставного отростка влечет смещение подбородка в сторону повреждения. При огнестрельных ранениях размеры повреждения мягких тканей бывают более значительны, чем костные поражения; поэтому на основании внешних впечатлений, подчас очень тягостных, нельзя судить о размерах костных повреждений. Более определенные заключения должны быть сделаны на основании дополнительного ощупывания. Здесь, как и при всяких переломах, основным симптомом является подвижность отломков. Рентгенография. С х е м а п о м о щ и . 1. Остановка кровотечения путем тампонады, перевязка кровотокающего сосуда, обшивание. Восстановление неподвижности костных отломков также способствует остановке кровотечения. Обработка раны проводится по общим правилам. Полость рта должна быть очищена от свободно лежащих осколков кости и зубов, мягкие ткани — от сгустков крови. Крайне бережно следует отнестись к зубам и костным отломкам, не потерявшим связи с надкостницей. Сильно расшатанные или висящие на лоскуте десны зубы следует сразу удалять. Должны быть удалены также части альвеолярного отростка, потерявшие связь с основной костной массой и лишь частично прикрепленные к мягким тканям. Наложение швов на кожу и слизистую, главным образом губ, при загрязненных, открытых переломах должно производиться крайне осторожно. Основным мероприятием должно быть правильное расположение лоскутов мягких тканей и сближение их краев, что достигается при помощи наложения фиксирующих швов (но не зашивания раны наглухо) и липкого пластыря.

2. Восстановление нормальных условий дыхания, что иногда достигается после очистки полости рта и зева от инородных тел и сгустков крови. При переломах тела нижней челюсти (смещение кзади отломка челюсти, несущего прикрепление подбородочно-язычных и подъязычных мышц) необходимо сначала захватить язык и вытянуть его, а затем фиксировать в нормальном положении отломки челюсти, чтобы предотвратить асфиксию.

3. Установка нормальных соотношений между отломками челюсти. Сначала нужно установить правильное соотношение отломков челюсти, а затем зафиксировать отломки в этом положении.

Наиболее простым критерием для суждения о правильности положения отломков является соотношение зубных дуг. В свежих случаях восстановление отломков удается обыкновенным переме-

## III

нием: при фиксированной голове каждый отломок челюсти захватывают пальцами руки снаружи и изнутри и с помощью небольшого насилия приводят под контролем глаза в правильное положение. При оскольчатом переломе необходимо установить правильное соотношение главных отломков. При множественном переломе нижней челюсти у людей с сильно развитыми мышцами отломки не могут быть приведены в правильное положение без вытяжения шинами. В таких случаях оказание первой помощи должно быть сведено к фиксированию отломков.

**Простейшие способы закрепления челюстных отломков в порядке оказания первой помощи.** 1. Фиксирующая повязка, назначение которой укрепить отломки челюсти, лишить их подвижности, уничтожить внутриротовую травму, возникающую в результате трения отломков и мягких тканей друг о друга. Повязку накладывают на несколько часов и применяют лишь в тех случаях, где более совершенная фиксация челюстных отломков не может быть произведена. Фиксирующую повязку накладывают таким образом, чтобы с помощью марлевого или полотняного бинта отломки челюсти были подвязаны к противоположной сохранившейся челюсти. 2. Межчелюстное скрепление, которое дает более надежную фиксацию отломков челюсти. Оно накладывается следующим образом. На верхней челюсти при помощи проволоочной лигатуры укрепляют крючок. Таким же образом укрепляют крючок (один или два<sup>^</sup> на соответствующем отломке нижней челюсти. Между верхним и нижним крючком натягивают проволоочное или резиновое (из дренажной трубки) колечко. С помощью колечка отломок нижней челюсти подтягивают и фиксируют. 3. Наложение проволоочной внутриротовой шины, которое является простейшим способом лечебного закрепления челюстных отломков. Такая шина выгибается из проволоки без приготовления гипсовых моделей, на глаз. Наиболее целесообразной является толщина проволоки 1—2 мм. Желательно пользоваться круглой алюминиевой проволокой или проволокой из нержавеющей стали.

Изготовив шину и пригнав ее так, чтобы она хотя бы в одной точке прилегала к каждому зубу, накладывают и укрепляют ее. В результате зубы как бы привязываются к шине, остатки челюсти повисают на проволоочной дуге, концы которой неподвижно закреплены. Никаких специальных приспособлений и оборудования для оказания первой помощи не требуется. Необходимо лишь иметь щипцы-плоскогубцы, кусачки и проволоку диаметром 1—2 мм для дуги и 0,1 мм для лигатуры.

**ПЕРИОДОНТИТ, ПЕРИЦЕМЕНТИТ (PERIODONTITIS, PERICEMENTITIS).** Инфекция пульпы и последующий некроз влекут за собой заражение и воспаление периодонта — периодонтит. Инфекция может быть внесена и в процессе зуболечебной работы при механической и медикаментозной обработке корневого канала. Известное значение в развитии периодонтита играют также механические или химические факторы — травматический периодонтит, химический периодонтит.

**Периодонтит острый (periodontitis acuta).** С и м п т о м ы и т е ч е н и е . В начальных стадиях больной жалуется на болезнен-

ность при надавливании и надкусывании на определенный зуб. Затем боли принимают самостоятельный характер: тянущие, ноющие, иногда пульсирующие. При надавливании на пораженный зуб боли усиливаются. Больной почти всегда правильно локализует свои болезненные ощущения. Одновременно с развитием болей больной сообщает, что зуб кажется ему приподнявшимся, как будто выросшим. При постукивании по зубу ощущается боль. При разлитом остром периодонтите даже легкое прикосновение к зубу вызывает боль. Дальнейшие исследования обнаруживают расшатанность зуба, гиперемизацию и отечную десну в области пораженного зуба и периостатическую боль при надавливании на десну соответственно проекции верхушки больного корня. При обильном количестве гноя наблюдается его истечение из-под края десны или образование поддесневого гнойника (parulis) главным образом в том месте, где слизистая десны переходит на щеку или губу. Отек щеки, увеличение и болезненность подчелюстных желез.

Периодонтит хронический (periodontitis chronica). Симптомы и течение. Очень незначительные и неопределенные боли, отек десны, наличие свищей, периодические припухания десны. Наиболее детальные сведения при скрыто текущих периодонтитах дает рентгенологическое исследование.

Лечение проводится двумя способами: 1) медикаментозное лечение, направленное главным образом на антисептическую обработку корневого канала и его содержимого: трикрезолфор-малин, камфофенол, антиформин, 3% раствор азотнокислого серебра или слабые антисептики в виде 0,7% раствора фтористого натрия; 2) хирургическое лечение, применяемое в случаях гранулы и корневых кист; сущность его состоит в удалении инфицированной верхушки корня и окружающих ее грануляций и капсулы на однокорневых зубах.

Первая помощь (лечение зубной боли).

1. При только что начавшемся периодонтите производится смазывание слизистой оболочки десны йодной настойкой соответственно проекции верхушки корней.

2. В начальных стадиях и при развившемся периодонтите рекомендуется раскрыть зуб (удаление пищевых остатков, вскрытие полости зуба бором). Каналы освобождаются от содержимого мягкого распада с помощью нервэкстрактора через слой 50% анти-формина, налитого в устье канала, или через слой 2% раствора азотнокислого серебра, или 2% раствора хлорамина.

3. Хорошее действие при острых периодонтитах оказывает введение в канал нескольких капель 2—3% раствора азотнокислого серебра. Для ускорения процесса восстановления рекомендуется после введения азотнокислого серебра прибавить несколько капель 4% спиртового раствора пирогалловой кислоты или танпина, или гидрохинона.

4. В тех случаях, когда зуб не удается вскрыть, рекомендуется произвести проникающий до кости разрез в области верхушки больного и двух соседних зубов, по переходной складке десны. При гнойных периодонтитах, при наличии отечной десны или обозначившемся гнойнике разрез десны и надкостницы особенно необходим.

5. В случае бурно протекающего периодонтита, когда не удастся ни уменьшить боль, ни замедлить развитие процесса, приходится прибегать к экстракции зуба.

6. Боли, возникающие вследствие лимфаденита подчелюстных желез, утихают под действием сухого тепла (грелки шесть раз в день по 15 минут), синего света по 20—20 минут несколько раз в день, соллюкса — расстояние 10—15—20 см, продолжительность 30—60 минут.

7. Для успокоения болей одновременно назначают внутрь аспирин, фенацетин, люминал, пирамидон, хинин и т. п.

Rp. Luminal) 0,075

Phenacetini

Coffeini natrio-benzoici aa 0,1 D. t.

d. N. 10

S. По 1 порошку 3 раза в день в полустакане теплой воды

Rp. Aspirini

Pyramidoni aa 0,2

Coffeini natrio-benzoici 0,1

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Rp. Phenacetini 0,25

Aspirini 0,12

Coffeini natrio-benzoici 0,01 M. f. pulv.

D. t. d. N. 12 S. По 1 порошку 3—4

раза в день

ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ (DENTITIO). У человека прорезываются 20 молочных зубов и 32 постоянных зуба. В состав молочного прикуса входят следующие зубы на каждой половине челюсти: 2 резца — центральный и боковой, 1 клык, 2 моляра. Прорезывание происходит в период от полугодичного возраста до 2½ лет.

Период прорезывания постоянных зубов начинается с 6 лет и заканчивается в основном к 13 годам, в 18—20 лет обычно прорезываются постоянные третьи большие коренные зубы — зубы мудрости. Постоянный прикус состоит из следующих зубов на каждой половине челюсти: 2 резца — центральный и боковой, 1 клык, 2 премоляра, 3 моляра. Все зубы, кроме больших коренных, прорезываются в качестве заменяющих молочные зубы. Большие коренные зубы (моляры), прорезываясь, удлиняют зубной ряд.

Сроки прорезывания молочных зубов: 6 месяцев — первые резцы, 8 — вторые резцы, 12 — первые моляры, 16 — клыки и 20 месяцев — вторые моляры. Сроки прорезывания постоянных зубов: 5—7 лет — первый моляр, 5—9 — первый резец, 6—10 — второй резец, 9—13 — первый премоляр, 10—15 лет — второй моляр.

Обычно прорезывание молочных и постоянных зубов происходит безболезненно. Исключением являются третьи моляры, которые, прорезываясь при сформировавшемся прикусе, нередко осложняются периоститом (периконаритом).

**ПУЛЬПИТ (PULPITIS).** В результате кариозного процесса открывается доступ в полость зуба для микроорганизмов, которые, проникнув через дентин, вызывают воспаление зубной мякоти — пульпит.

**ПУЛЬПИТ ОСТРЫЙ (PULPITIS ACUTA).** Симптомы и течение. Боль характеризуется тремя основными признаками: 1) она самопроизвольна, остра, жгуча; 2) приступообразна; 3) не локализована, иррадирует, распространяется по ветвям тройничного нерва. При осмотре полости рта обнаруживается пораженный зуб.

**ПУЛЬПИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (PULPITIS CHRONICA).** Симптомы и течение. Болевой симптом не имеет такого яркого выражения. Хронические пульпиты протекают большей частью в открытой форме, и пульпа может быть обнаружена при осмотре полости зуба: на дне глубокой кариозной полости виднеется пульпа в виде темнокрасной точки, сильно кровоточащей и умеренно болезненной при зондировании. В других случаях часто наблюдается сильно разрушенная кариозная коронка, полость которой выполнена кровоточивыми и безболезненными при неглубоком зондировании грануляциями.

**ПУЛЬПЫ ГАНГРЕНА (GANGRAENA PULPAE).** Симптомы и течение. Зуб внешне изменен в окраске: он темнее здоровых зубов. Холод и химические раздражители не вызывают болевой реакции. Такое ареактивное состояние зуба рано или поздно прекращается — гангрена клинически осложняется. Обычное осложнение — острое или подострое воспаление периодонта. Газообразные продукты, образующиеся при разложении пульпы, не имея выхода наружу, давят на периодонт; появляются жестокие боли периодонтального характера.

**Лечение болезней пульпы.** Основной принцип лечения воспаленной пульпы состоит в умерщвлении (девитализации) и удалении заболевшей части пульпы: наложение крупинки пасты из мышьяковистой кислоты на пульпу. Через 24—48 часов пульпа некротизируется и может быть безболезненно удалена.

Rp. Ac. arsenicosi 6,0  
Cocaini -hydrochlorici 1,0  
Phenoli 1,0  
Glycerini q. s. ut fiat pasta mollis DS.  
Мышьяковая паста для девитализации пульпы

Умерщвленную пульпу удаляют полностью — экстирпируют или частично ампутруют. Экстирпационный метод состоит в удалении коронковой части пульпы и извлечении корневой пульпы из канала. Извлечение производится с помощью специально зазубренной иглы — нервэкстрактора. После удаления пульпы ее ложе (камера и канал) обрабатывают антисептическими жидкостями и выполняют каким-нибудь отвердевающим материалом — цементом или пастой. При ампутационном методе удаляют коронковую часть пульпы и из устьев канала, а корневую пульпу подвергают муми-

фикации, для чего ее обычно пропитывают трикрезолформалином, или консервации 0,7% фтористым натрием, натрий-хлорфенолом.

**Первая помощь (лечение зубной боли).** Для успокоения боли необходимо установить наличие больного зуба. Обнаруженную кариозную полость следует очистить от пищевых остатков (пинцетом, промыванием теплой водой), удалить часть размягченного дентина со дна полости с помощью экскаватора (осторожно) или обыкновенной острой ложечкой небольшого размера. Затем зуб высушивают ватным тампоном и ограждают ватным валиком, заложенным между десной и щекой (или губой) от доступа слюны. На маленьком ватном шарике в полость зуба вводят болеутоляющее средство, а поверх шарика без давления накладывают густо пропитанный коллодием ватный тампон. В качестве болеутоляющего средства применяют фенол (Ac. carbolicumliquesfactum) и кокаин. Порошок кокаина замешивают фенолом или гвоздичным маслом до кашицеобразной консистенции и часть массы величиной с просыное зерно закладывают в кариозную полость. При лечении детей кокаином пользоваться не следует.

**СТОМАТИТЫ.** Стomatит катаральный, или простой, поверхностный, гингивит (gingivitis simplex). Симптомы и течение. При острой форме — гиперемизированная и отечная слизистая оболочка, местами (у десневого края, на местах отложения зубного камня, вблизи кариозных зубов) — эрозии. Сглаживается отчетливость рисунка десневого края, десневые сосочки набухают, закругляются, десна нависает над поверхностью зуба. При значительных поражениях десен укрепление зубов в альвеолах ослабевает. Язык сначала покрывается светлым, затем коричневым налетом, отекает. На слизистой щек и языка появляются отпечатки зубов. Слюнотечение. Возможен запах изо рта. Акт жевания болезнен. Обычно острая форма длится 1—2 недели, после чего болезнь заканчивается, принимает хроническое течение или же переходит в глубокую форму.

**Стomatит фибринозный или афтозный (stomatitis fibrinosa).** Возбудителями афт считаются стафилококки, стрептококки, диплококки, фильтрующий вирус. Поражаются преимущественно дети в возрасте от 1 года до 3 лет, но заболеть могут и дети других возрастов и взрослые, особенно во время гриппа.

**Симптомы и течение.** Общее недомогание, разбитость, субфебрильная температура, познабливание. На слизистой поражение локализуется чаще в области переходной складки; у края или нижней поверхности языка, реже на деснах, отчетливо видны белые или желтоватые бляшки, большей частью овальной или круглой формы. Бляшки сидят на несколько гиперемизированной слизистой. Особенно резкое покраснение наблюдается в виде ободка вокруг самой бляшки; к периферии краснота уменьшается. В редких случаях бляшки бывают единичными.

Помимо явлений общей интоксикации, у больного нарушается акт речи, особенно при поражении языка, и затрудняется прием пищи, глотание; болезненность особенно усиливается при малейшем прикосновении. Заканчивается выздоровлением, но возможно прогрессирование заболевания, слияние отдельных бляшек, инфекция

более глубоких слоев слизистой оболочки, т. е. возникновение язвенного стоматита.

Стоматит хронический, лейкоплакия (**leucoplakia**). С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Изменение цвета слизистой оболочки (краснота, цианоз), утолщение всей массы десны. Разлитое утолщение десны хронически воспалительного характера носит название гипертрофического гингивита.

При наличии длительных раздражений (курение, алкоголизм, сифилитическая инфекция) нередко встречается поверхностное хроническое воспаление слизистой оболочки рта, носящее название лейкоплакии. На слизистой оболочке, главным образом на средней трети спинки языка, боковой поверхности его, слизистой щеки вблизи угла рта, слизистой нижней губы появляются белесоватые пятна.

Лейкоплакия редко исчезает самостоятельно и с большим трудом поддается лечению. Иногда у больных, страдавших лейкоплакией языка, развивается рак языка. Это обстоятельство заставляет расценивать в некоторых случаях лейкоплакию как предраковое состояние. Такой больной должен находиться под постоянным наблюдением, чтобы при появлении первых симптомов рака диагностировать его в ранней стадии развития. Весьма подозрительно обострение течения болезни: лейкоплакия распространяется, белесоватый цвет приобретает буроватый оттенок, место поражения уплотняется, появляются болезненные трещины и изъязвления. Все эти изменения должны расцениваться как предраковое состояние.

Стоматит язвенный, или гангренозный (**stomatitis ulcerosa**). С и м п т о м ы и т е ч е н и е. Все слои значительного покрова некротизируются, образуя небольшие язвы; изъязвляется соединительная ткань, иногда некротизируется и кость. На деснах поражение чаще всего возникает у края на протяжении одного или нескольких зубов. Десна становится отечной и гиперемированной, а края ее покрываются каймой грязносерого цвета. По снятии серой некротической ткани обнажается язвенная поверхность. Изъязвления проявляют склонность проникать вглубь ткани. Обычные размеры язв не превышают 1 см.

Одной из тяжелых форм язвенно-гангренозного стоматита является нoma. Поражает детей, организм которых ослаблен острыми инфекционными заболеваниями. На определенном участке омертвевает вся толща щеки. Поражение располагается на слизистой щеки между углом рта и выходным отверстием стенового протока. В случае выздоровления проникающая язва щеки отграничивается, и процесс заканчивается образованием рубцов вокруг дефекта. Эти грубые рубцы нередко ограничивают подвижность нижней челюсти, задерживая ее развитие, и ведут к ее деформации, образованию характерного «птичьего лица».

Л е ч е н и е всех форм стоматитов. Поднятие питания организма умелым установлением диеты, введением витамина С. Раздражающие моменты во время питания должны быть устранены, и в то же время питание должно оставаться качественно ценным. В редких случаях его прибегают к методам внеротового питания: капельные и питательные клизмы, питание через нос. При эпидемических фор-

мах стоматита особое внимание должно быть обращено на санитарно-гигиеническую сторону быта.

Важно исключить местные причины, оказывающие вредное воздействие на слизистую оболочку: удалить зубной камень, устранить травмирующие слизистую остатки зубов, протезы и т. п., совершать ежедневный туалет полости рта (удаление влажным тампоном налетов некротического распада десен, языка, щек); лишь при наличии язвенных процессов надо активизировать гранулирование и эпителизацию язв, смазывая язвенные поверхности 2—3% раствором азотнокислого серебра.

При хроническом -стоматите или переходе острых процессов в подострые желательны назначение вяжущих средств. При острых формах стоматита полость рта орошают из спринцовок, а еще лучше из кружки Эсмарха 1—2 раза в день.

При лечении лейкоплакии необходимо прекратить курение, запретить горячую, обжигающую рот пищу. Корни зубов должны быть удалены, а зубы тщательно запломбированы. Особенно нужно следить за гигиеническим содержанием протезов, если таковые имеются. В случаях появления трещин, язв наиболее радикальным способом является иссечение пораженных мест с наложением первичного шва, лечение радием.

Дезодорация (устранение запаха) достигается полосканием или промыванием раствором марганцовокислого калия, перекисью водорода. Предварительно необходимо прополоскать рот содовым раствором.

Наиболее часто назначаемые полоскания: двууглекислая сода — чайная ложка на стакан воды; перекись водорода — чайная ложка на стакан воды; йодная настойка — 10 капель на стакан воды; 0,5% раствор тимола; 0,5% раствор марганцовокислого калия; 3% раствор борной кислоты; 3% раствор салициловой кислоты в спирту; глицерин; 3% раствор буры (особенно при афтах); листья шалфея (*folia Salviae*); цветы ромашки (*flores Chamomillae*); риванол (1 : 1 000). Присыпка белой глиной ускоряет заживление.

Уход за з у б а м и. Так как самоочищение полости рта обычно бывает недостаточным, приходится прибегать к мерам индивидуального ухода за зубами. Целью ухода является устранение пищевых остатков и налета. Уход за полостью рта является одним из мероприятий личной гигиены каждого человека.

Здоровые новорожденные дети и дети до 2—3-летнего возраста не нуждаются в специальном уходе за полостью рта, так как анатомические и физиологические особенности полости рта в этом возрасте содействуют самоочищению (обильное слюноотделение, частые приемы пищи, обилие жидкой пищи, отсутствие или небольшое количество зубов). Протирание полости рта, всякие смазывания слизистой оболочки у здоровых детей грудного возраста не только бесполезны, но даже вредны.

Средствами очистки полости рта являются полоскания и чистка зубов щеткой. Чистке щеткой подлежат все поверхности зуба — щечная, язычная и жевательная! Особое внимание надо уделять очистке межзубных пространств, что достигается только при помощи

хорошо сделанной щетки. Такая щетка должна обладать следующими свойствами (модель автора):

1. Размер рабочей части щетки должен быть не очень велик, чтобы ею можно было пользоваться для обработки язычных поверхностей зуба, — не больше 4 см в длину.

2. Щетинки на щетке должны быть расположены в виде отдельно собранных и редко насаженных пучков. Это необходимо для того, чтобы пучок проникал в промежутки между зубами и действовал наподобие зубочистки. С этой же целью каждый пучок должен быть подстрижен и иметь форму конуса. Редкая рассадка пучков, кроме того, облегчает промывку и просушку щетки после употребления.

3. Поверхность щетки должна быть слегка изогнутой — в соответствии с изгибом зубной дуги.

4. Щетинки щетки должны быть в достаточной степени эластичными и не слишком жесткими; эластичные щетинки легко поддаются давлению пальцем.

5. Ручка щетки должна быть плотной, напористой, гладкой, непроницаемой для воды. Этим требованиям отвечает кость и пластмасса.

6. Зубная щетка и укрепление щетинок должны быть прочными, чтобы можно было погружать ее в теплую и даже горячую воду.

Щетку необходимо держать в чистоте. Загрязненная щетка приносит больше вреда, чем пользы. После употребления щетку надо обязательно промыть и высушить и лишь после этого спрятать в ящик или коробку. Оставлять щетку в стакане на умывальнике, полке, столе не следует. Каждый член семьи должен пользоваться только своей щеткой; то же относится к щеткам больных. При наличии поражения в полости рта надо приобрести новую щетку. После каждой чистки щетка должна быть промыта теплой водой с мылом и посыпана роллю, которую смывают перед употреблением щетки.

Чистка зубов производится следующим образом. Сначала рот прополаскивают водой комнатной температуры для того, чтобы механически, струей воды, смыть скопление слизи и остатков пищи. К стакану воды рекомендуется прибавить  $>1/4$  чайной\*ложки пищевой соды (*Natrium bicarbonicum*) или столовой соли (*Natrium chloratum*), чтобы облегчить растворение слизи. Затем зубную щетку смачивают водой, стряхивают и погружают в зубной порошок таким образом, чтобы к кончикам щетинок во всей поверхности щетки пристало небольшое количество порошка. Очистка зубов производится как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Ведением щетки только по вертикальной оси зуба, как некоторые предлагают, нельзя достигнуть достаточной очистки межзубных пространств. Как уже упоминалось, очистке подлежат все поверхности зуба. После очистки рот снова прополаскивают, чтобы удалить остатки зубного порошка, слизи и остатки зубных наложений.

В качестве средства для очистки зубов следует рекомендовать зубной порошок или пасту. С целью исправления неприятного для некоторых вкуса и запаха влажного мела к зубному порошку прибавляют небольшое количество какого-нибудь эфирного масла, например, мятного. Можно применить и другую отдушку. Зубной порошок должен быть равномерно и весьма тщательно измельчен

(*pulvis subtilissimus*). Наиболее совершенной является величина измельченной частицы не выше 0,1  $\mu$ . В состав зубного порошка входят вещества, оказывающие преимущественно механическое, абразивное (стирающее) действие на поверхность зубной эмали. Однако это действие должно оставаться мягким: порошок не должен стирать эмалевый покров. Действие его должно приближаться к полировке, подобной той, которая происходит в естественных условиях при акте жевания. Этим требованиям больше всего отвечает углекислая магнезия (*Magnesium carbonicum*) и углекислая известь (*Calcium carbonicum*). Оба вещества представляют тонкий порошок, образованный округлыми частицами одинакового размера. У магнезии более тонкий помол, чем у кальция. Углекислая известь в значительном количестве входит в состав мела, из которого обычно готовится зубной порошок. Однако мел лишен однородности углекислой извести в отношении твердости частиц и обычно содержит примесь более плотных веществ, например, частиц песка. У некоторых людей зубной порошок из мела обуславливает значительное стирание эмали, образует клиновидные дефекты. В этих случаях следует отдать предпочтение осажденной углекислой извести, белой глине (*bolus alba*). Если частица порошка не превышает 0,1  $\mu$ , то стирающее действие минимально.

Химического действия зубного порошка следует избегать. Абсолютно противопоказано прибавление к пасте или б, оному порошку органических кислот, например, виннокаменной кислоты, которая входит в состав некоторых паст и тем более соляной кислоты, используемой для отбеливания зубов. Прибавление салициловой кислоты, бертолетовой соли также излишне.

Мыла (даже специальные зубные) применять не следует, так как при соприкосновении с так называемой жесткой, содержащей кальций водой мыло разрушается и освобождает едкое кали, вредно действующее на слизистую оболочку и эмаль. Окисляющие вещества, особенно перекись водорода, также нежелательны, так как нередко повышают чувствительность поверхности зуба к температурным и химическим раздражителям.

При функциональной и анатомической недостаточности эмали и наклонности ее к стиранию предпочтительно применять белую глину. Хороша в таких случаях щелочная паста, в состав которой входит сода, бура, осажденный кальций, магнезия. Зубные пасты по эффекту очистки уступают порошку, но в дороге, в походе они удобнее, так как не рассыпаются и хорошо сохраняются в гигиенических металлических трубках. Однако необходимо знать состав пасты, прежде чем ее рекомендовать, чтобы быть уверенным в том, что она не содержит раздражающих и вредных для слизистой оболочки и эмали веществ, например, кислот и едких щелочей.

На основе сказанного можно рекомендовать следующие прописи зубного порошка.

Rp. *Calcii carbonici* 40,0  
*Magnesii carbonici* 20,0 01.  
*Menthae pip. gtt.* X M. f. pulv.  
*dentifricus* DS. Зубной порошок

- Rp. Magnesii carbonici 50,0 01. Menthae pip. gtt.  
X M. f. pulv. dentifricus DS. Зубной порошок при стирании эмали
- Rp. Magnesii carbonici 40,0 Natrii bicarbonici 10,0  
01. Menthae pip. gtt. X M. f. pulv. dentifricus S.  
Зубной порошок при чувствительности шеек
- Rp. Boli albi 50,0  
01. Menthae piperitae gtt. X  
DS. Мягкий порошок по Лукомскому

Для полоскания здоровой полости рта применяют обыкновенную воду с небольшим количеством двууглекислого или хлористого натрия, рассчитанного на механическое, а не антисептическое действие. Антисептическое действие жидкостей при полоскании полости рта вообще весьма проблематично, так как слабые растворы антисептиков недостаточно эффективны, а сильные концентрации недопустимы вследствие их раздражающего действия на слизистую оболочку.

В некоторых случаях при наличии запаха изо рта приходится прибегать к устраняющим или уменьшающим его дезодорирующим веществам. К таким средствам относятся марганцовокислый калий (Kalium hypermanganicum) в 0,5—0,25% растворе и перекись водорода (Hydrogenium hyperoxydatum) в 0,5—1% растворе. В качестве улучшающих вкус, освежающих полосканий (зубной элексир) можно назначать следующие полоскания.

- Rp. Thymoli 1,0  
Alcoholi 100,0  
01. Menthae piperitae gtt. XX  
MDS. Несколько капель на стакан воды — полоскание
- Rp. T-rae Myrrhae  
T-rae Ratanhiaе \_\_\_\_\_  
T-rae Callarum aa 10,0 MDS. По 20 капель на стакан теплой воды — полоскание
- Rp. Ac. borici  
Thymoli  
Mentholi aa 0,5 01. Eucalypti 2,5  
Spiritus Vini 150,0 Aq. destill. 100,0  
MDS.  $\frac{x}{2}$  чайной ложки на стакан воды — полоскание



Вопрос о том, сколько раз в день надо чистить зубы, различные авторы решают по-разному. Несомненно, что наибольшее скопление нищевых остатков бывает к вечеру, а наибольшее количество налета — по утру. Поэтому необходимо два раза в день — вечером перед сном и утром после сна — производить очистку полости рта. На ночь необходимо чистить зубы и полоскать рот. Утром можно ограничиться одним полосканием или, наоборот, на ночь можно полоскать рот, а утром полоскать рот и чистить зубы. Эти мероприятия мы считаем минимальными. Лучший эффект достигается при чистке зубов перед сном и после сна. Слишком часто чистить зубы не следует, так как это наносит вред слизистой и зубам.

Носители зубных протезов (искусственных зубов) должны особенно внимательно очищать их щеткой и мелом. Съемные протезы необходимо вынимать перед сном, очищать щеткой, обмывать в теплой воде и, вытерев насухо, убирать в ящик или коробку. Широко распространенная привычка - погружать протез на ночь в стакан с водой нецелесообразна, так как, находясь в воде, содержащей микробов, протез загрязняется.

**УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА БОЛЬНОГО.** Особенного внимания требует уход за полостью рта больного. У лихорадящих больных язык часто бывает обложен налетами, и на зубах также скапливается слизистый налет, особенно у левого края. Тяжело больные не могут сами ухаживать за полостью рта, и эта обязанность падает на ухаживающий персонал. Уход за полостью рта больного осуществляется по преимуществу с помощью протирания и промывания. Зубную щетку у тяжело больных применять не рекомендуется, так как ею можно сильно повредить слизистую оболочку десен.

Протирание производится с помощью ватного шарика, смоченного в 0,5% растворе соды, хлористого натрия или 5% растворе буры (borax). Ватный шарик захватывают пинцетом и каждый зуб протирают отдельно со всех сторон. Особенно тщательно следует протирать зуб у его шейки. Эта процедура обычно утомляет больного, так как ему приходится сидеть с открытым ртом. Поэтому протирание должно производиться с небольшими перерывами. При протирании верхних коренных зубов следует хорошо оттянуть щеки, чтобы не внести инфекцию в выводящий проток околоушной железы, расположенный на слизистой щеки в области первого и второго моляров (максимальное оттягивание щеки достигается при не вполне открытом рте, когда ткани щеки не напряжены). По этой же причине, т. е. во избежание заноса инфекции в околоушную железу и последующего паротита (воспаления околоушной железы), слизистую щек протирать не рекомендуется.

Язык также необходимо очищать. Очистку производят с помощью шпателя. Повернув шпатель ребром, проводят им несколько раз по спинке языка.

Промывание полости рта лучше всего производить из шприца типа Жане, обычно употребляемого в урологии, или из кружки Эсмарха, резинового баллона. Чтобы предотвратить затекание жидкости в дыхательные пути, промывание следует производить в сидячем или полусидячем положении больного с несколько наклоненной вперед головой. Чтобы не замочить белья, больному подвязывают

клеенчатый фартук, и санитарка держит плотно прижатый к его подбородку лоток.

Для промывания применяют слабые растворы соды (0,5%), хлористого натрия (0,9%), буры (2—5%), марганцовокислого калия (1 : 10 000), перекиси водорода (0,5%), риванола (1 : 1 000).

При заболевании или повреждении слизистой оболочки рта орошение (ирригация) полости рта является одним из наиболее действенных средств, и промывание нередко назначают по несколько раз в день (2—3 раза). Помимо механической очистки, которая достигается при помощи промывания, орошение оказывает и лечебное действие вследствие раздражения струей жидкости тканей.

Уход за хирургическими больными с поражениями полости рта и челюстей проводится на общих основаниях, принятых в хирургической клинике. Каждый больной, перенесший длительное лихорадочное заболевание, по выздоровлении должен произвести чистку зубов у зубного врача.

**ЭКСТАРКЦИЯ ЗУБОВ.** Показания к удалению постоянных зубов относительны. Главным образом удаляют зубы с некротизированной пульпой, которые в силу тех или иных причин не могут быть излечены, затем зубы, интактные вследствие значительного расшатывания, неправильного положения и т. д. В порядке неотложной помощи показана безусловная экстракция при остром бурно развивающемся периодонтите, при угрозе его перехода в остеомиелит.

Показания к удалению молочных зубов. Удалению подлежат зубы или их остатки: 1) при наличии прорезавшихся или прорезывающихся зубов постоянного прикуса; 2) с поражением периодонта, не поддающиеся излечению или временному сохранению.

Противопоказания к экстракции зуба относительны. Особенно опасно распространение инфекции при удалении зуба в период острого остеомиелита челюсти. В этом случае экстракция как самодовлеющее мероприятие без дополнительного разреза нежелательна. Рекомендуется воздержаться от экстракции при наличии вирулентной инфекции в полости рта или зева (стрептококковая ангина, дифтерия и т. п.), герпеса, в ближайшие недели после аборта.

Длительное, трудно ликвидируемое кровотечение может возникнуть после экстракции зуба у больного, страдающего геморрагическим диатезом (гемофилия), тромбопенией, цыгной или заболеванием, сопровождающимся геморрагическими симптомами (желтуха, лейкопения и т. д.). Поэтому показания к экстракции в таких случаях должны быть тщательно взвешены; в случае необходимости экстракции следует предпринять ряд мер для предупреждения послеэкстракционного кровотечения и борьбы с уже возникшим кровотечением.

Экстракция противопоказана при острой декомпенсации сердечной деятельности.

Обезболивание. Наиболее применима местная анестезия новокаином.

Rp. Sol. Novocaini 1% 30,0  
Sterilisetur! DS. Для  
инъекций

Подготовка и положение больного. Необходимо строжайшее соблюдение асептики; желательна предварительная анестезия. Непосредственная подготовка полости рта состоит в его прополаскивании для удаления пищевых остатков. Если зуб покрыт камнем, его необходимо предварительно удалить. Непосредственно перед экстракцией рекомендуется внимательно осмотреть подлежащий удалению зуб, определить на глаз и с помощью пинцета крепость его стенок, проверить подвижность, соотношение со стоящими рядом зубами и т. д. Необходимо обеспечить правильное освещение и удобный подход к области, в которой предположено произвести экстракцию. Для этого при удалении верхних зубов больного усаживают повыше с закинутой головой; при удалении нижних зубов его удобнее посадить ниже, голова должна находиться в прямом положении или слегка наклоняться вперед. Необходимо прочно фиксировать голову. На стуле, снабженном спинкой и подголовником, голова больного получает достаточный упор. Пальцы левой руки экстрагирующего, с помощью которых отодвигаются мягкие ткани, фиксируют альвеолярный отросток и челюсть в процессе экстракции и в то же время содействуют фикс: дии всей головы, опирающейся на подголовник. При отсутствии подголовника, когда больной сидит на табурете, следует вплотную подойти к нему сзади, став сбоку, справа, и перекинуть левую руку через голову больного таким образом, чтобы она оказалась зажатой между плечом и грудью экстрагирующего, а предплечье оставалось свободным для фиксации альвеолярного отростка левой кистью.

Для удаления нижних левых зубов удобнее становиться с левой стороны больного; если оно производится с помощью изогнутых по плоскости щипцов, нужно становиться впереди больного.

Послеэкстракционные кровотечения.

1. Предварительно необходимо успокоить больного. Затем его усаживают или укладывают в таком положении, чтобы место кровотечения удобно было осмотреть. Из луночки послеэкстракционной раны и в ее окружности струей воды из шприца удаляют сгустки крови.

Путем осмотра устанавливают источник кровотечения (луночка, десневой край, глубокие слои десны).

2. При наличии луночкового кровотечения и совместного кровотечения из луночки и десневого края применяют тампонаду луночки. В качестве материала употребляют узкую (0,5—1 см) полоску нодоформной марли. Тампонаду начинают со дна альвеолы мелкими складками, плотно придавливая и туго набивая воронку альвеолы; альвеола как бы пломбируется марлевой лентой. Поверх тампона накладывают небольшой марлевый шарик и предлагают больному стиснуть зубы. Больного следует держать под наблюдением в течение  $\frac{1}{2}$ —1 часа, чтобы убедиться в отсутствии кровотечения. При непрекращающемся кровотечении необходимо удалить только что заложенный тампон и вновь самым тщательным образом повторить

всю процедуру. Марлевый шарик больной через несколько часов удаляет сам. Тампон в луночке должен оставаться несколько дней (2—4), до начала организации тромба, чтобы избежать повторения кровотечения. Полоскания, помимо обычных (утром и вечером), в первые сутки должны быть совершенно запрещены.

3. При разрыве десен и отсутствии кровотечения из луночки можно применить давящую повязку на щеку, наложенную таким образом, чтобы щека или губа была прижата вплотную и по возможности неподвижно к раневой поверхности. Иногда при более значительных разрывах в таких случаях приходится прибегать к наложению швов.

4. Если, несмотря на тщательную тампонаду, кровотечение не прекращается или имеются какие-нибудь основания предполагать, что одно это мероприятие не приостановит кровотечения, следует, помимо тампонады, применить впрыскивание лошадиной сыворотки. Тех. н и к а в в е д е н и я . Внутримышечная или подкожная инъекция 5—10 мл сыворотки. При отсутствии нормальной лошадиной сыворотки можно пользоваться другой лечебной сывороткой, например, противодифтерийной или противостолбнячной. При впрыскивании сыворотки, особенно при повторном введении, всегда нужно помнить о возможности анафилактики. Поэтому лучше вводить сыворотку в два приема: сначала небольшое количество (1—2 мл), после чего выждать 4—5 минут, следя за пульсом, дыханием и общим состоянием, и затем ввести оставшееся количество.

5. Затяжное кровотечение останавливается следующим образом. Рану освобождают от костных осколков, сгустков крови, высушивают тампонами, луночку изолируют от попадания слюны. С помощью шприца или марлевых турунд луночку наполняют тромбином, после чего рапу тампонируют. Поверх тампона накладывают марлевый или ватный шарик, также пропитанный тромбином. При упорном кровотечении процедуру повторяют.

**Незаконченная экстракция.** Незаконченная экстракция (*extractio incompleta*), по поводу которой больной направляется или сам обращается в амбулаторию, требует осторожного подхода. Общим правилом является стремление закончить экстракцию возможно раньше, чтобы избавить больного от болей, тризма, отека. Однако в некоторых случаях приходится отступать от этого правила. Не всегда после травматической экстракции, не доведенной до конца, после глубокого перелома корней или удаления лишь части корней удается достаточно точно ориентироваться в возникших новых топографических соотношениях. Не всегда в таких случаях имеется возможность обнаружить подлежащие удалению остатки зуба. Чтобы не итти на поиски с помощью долота или щипцов вслепую и не наносить новой бесполезной травмы, необходимо предварительно произвести рентгеновский снимок. При наличии гангренозной раны с некрозом и гангренозным распадом мягких тканей после незаконченной экстракции, произведенной за несколько дней до обращения больного за помощью по поводу перелома зуба, рекомендуется временно воздержаться от продолжения экстракции. Только в отдельных случаях при нарастании явлений периодонтита

приходится заканчивать экстракцию при переломах корня и в таких условиях.

Наконец, необходимо учесть общее состояние больного. Длительные и излишне настойчивые попытки во что бы то ни стало закончить экстракцию нередко доводят больного до очень тяжелого состояния; поэтому, если нет прямых показаний к непосредственному продолжению операции, рекомендуется экстракцию отложить.

Однако в большинстве случаев операционного перелома зуба не следует отказываться от доведения экстракции до конца.

**Послеэкстракционные боли.** Послеэкстракционная боль (*dolor post extractionem*) встречается нередко. В большинстве случаев в течение ближайшего после экстракции часа боль теряет свою остроту или окончательно стихает. Однако бывают случаи, когда острая боль упорно держится в течение многих часов, а иногда и дней. Такие случаи представляют довольно трудный объект терапии.

Исходной причиной послеэкстракционных лупочковых болей чаще всего является экстракционная травма. Опыт показывает, что чем больше травма после экстракции, тем чаще возникают луночко-вые боли в послеэкстракционном периоде. Однако не всегда можно установить такое соответствие. В некоторых случаях, несмотря на осторожно проведенную экстракцию, все же появляется упорная лупочковая боль. Для понимания этого явления необходимо уяснить существо травмы, вызываемой всякой экстракцией. При экстракции происходит следующее: 1) нарушение целостности связочного аппарата зуба и возникающий при этом разрыв нервов и сосудов; 2) механическое давление на стенки луночки и в той или иной степени возникающее при этом размождение нервных окончаний; 3) механическое проталкивание инфекционного материала в стенки луночки и расширение зоны распространения инфекции — вот основные явления, определяемые, в обобщенном виде термином «экстракционная травма». Эти явления возникают при всякой экстракции, но степень их выражения бывает различна, в зависимости от силы травмы и состояния тканей, которые подвергаются этой травме, т. е. характера распространения воспалительного процесса. В тех случаях, когда в силу той или иной причины эти явления достигают определенной высоты, возникает л у н о ч к о в ы й н е в р и т механического, токсического или инфекционного происхождения; обычно все три фактора имеются в основе послеэкстракционного луночкового неврита, но тот или иной фактор (механический, токсический, инфекционный) может преобладать.

В некоторых случаях возникают поздние луночковые боли, которые появляются спустя некоторое время после экстракции. Поздние луночковые боли большей частью возникают на почве развившегося остеомиелита луночки, обнаженного края луночки (альвеолит) или инфекции тромба, заполнившего луночку после экстракции. Послеэкстракционные боли не всегда бывают луночковыми, но могут зависеть и от острого аденита подчелюстных лимфатических узлов.

Лечение послеэкстракционных болей бывает различным, в зависимости от предполагаемой причины. При обнажении луночко-



вых краев показано скусывание выступающих частей кости. При наличии распавшегося тромба и инфицированных обрывков ткани в луночке или размягченной стенке луночки применяют выскабливание луночки острой ложечкой с последующим промыванием и рыхлой тампонадой луночки иодоформной марлей. Болеутоляющее действие приписывается анестезину, фенол-камфоре, хлоралгидрату.

Фенол-камфора применяется в следующей прописи.

Rp. Phenoli 10,0

Camphorae 20,0

DS. Вводить на тампоне в экстракционную рану

Анестезин на пинцете вводят в луночку.

В некоторых случаях достигается успех в результате применения спиртовых тампонов: полоску марли пропитывают 70% спиртом и вводят в луночку после предварительного ее выскабливания. Спиртовой тампон рекомендуется менять несколько раз в день.

Можно пользоваться пастой с 5% содержанием анестезина, составленной из равных частей пчелиного воска и персикового масла (И. Г. Лукомский). В освобожденную от сгустков крови луночку с помощью шпателя вводят на 1—2 дня пасту.

Rp. Anaesthesini 2,5 Cerae

flavi

01. Persicorum aa 25,0 M. ut fiat pasta DS.

Луночковая паста Лукомского

При наличии аденита показано применение сухого тепла, лампы соллюкс.

Хорошие результаты достигаются применением ультракоротковолновой или ультравысокочастотной терапии (УКВ, УВЧ).

Кроме того, при луночковых болях в качестве болеутоляющего назначают внутрь пирамидой, аспирин, фенацетин, люминал. Предпочтительнее пользоваться комбинацией этих веществ.

Rp. Luminali 0,05 Phenacetini 0,2

Pyramidoni 0,3 Coffeini natrio-benzoici

0,1 M. f. pulv. D. t. d. N. 10 S. По 1

порошку несколько раз в день

Rp. Phenacetini 0,2

Aspirini 0,3

Coffeini natrio-benzoici 0,1 M. f.

pulv. D. t. d. N. 10 S. По 1

порошку несколько раз в день

Предупреждение возникновения луночковых болей не всегда возможно, но стремление по возможности уменьшить размер послеэкстракционной травмы, устранение из луночки вслед за экстракцией тканевых обрывков и отломков путем выскабливания, обкусывание обнаженных стенок луночки — все это уменьшает частоту и силу послеэкстракционных болей. После заведомо травматической экстракции или при так называемой сухой луночке, не заполнившейся кровяным сгустком, следует заполнять луночку анестезино-вой пастой (рецепт см. выше). При упорных болях рекомендуется назначать ультравысокочастотную терапию.

## ГЛАВА XIV

## МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

**АУТОГЕМОТЕРАПИЯ.** Введение больному собственной крови. Необходимо иметь 5—10-граммовый шприц с иглами. После дезинфекции инструментов, рук и кожи больного в локтевом сгибе берут обычным способом (см. *Венепункция*) 3—5 мл крови и быстро вводят ее в заранее подготовленное место внутримышечно (см. *Впрыскивание внутримышечное*). Лучше всего вводить кровь в наружные мышцы бедра или в ягодицы. •

Иногда пользуются гемолизированной (лаковой) кровью. До взятия крови из вены в шприц набирают 8 мл воды двойной дистилляции, а затем в него же набирают 2 мл крови. Затем быстро извлекают иглу, 2—3 раза производят вращательные движения полным шприцем для лучшего смешения и растворения крови и быстро вводят содержимое шприца в соответствующее место.

**БАНКИ ВИРА.** Дно банки имеет широкое отверстие со стеклянным наконечником, на который надевается резиновый баллон. Чтобы поставить банку, следует выжать рукой воздух из баллона, плотно приставить банку к коже и постепенно отпускать баллон. Часть воздуха, находящегося в банке, перейдет в баллон, в банке получится отрицательное давление, и она присосется к коже. Чтобы снять бировские банки, следует вновь сжать баллон. Действие их аналогично действию обычных сухих банок.

**БАНКИ СУХИЕ.** Банки ставят на различные места тела, чаще на грудную клетку (при застое крови в малом кругу кровообращения, при воспалительных процессах в органах дыхания и пояснице).

Банки (до 20—30 в один прием) ставят больному в лежачем положении на ровное место, где нет костных выступов, углублений; на спине банки ставят под лопаткой, между позвоночником и лопаткой. Чтобы банки прилегали плотнее, кожу предварительно смазывают вазелином, особенно если тело покрыто волосами. Заранее готовят нужное количество банок и ставят их на столик около больного. На металлическую палочку с нарезкой или на пинцет навертывают сравнительно большой ватный тампон, который смачивают в спирту, зажигают и вводят снизу в полость банки, как бы смазывая ее, затем быстро вынимают пинцет и немедленно плотно приставляют банку к коже; тотчас берут следующую банку и ставят ее таким же образом рядом. Когда спирт на тампоне весь сгорит и начнет гореть вата, огонь тушат, тампон снова смачивают спиртом и зажигают; процедура повторяется до тех пор, пока не будут поставлены все банки. После того как банки поставлены, больного прикрывают одеялом; до снятия банок он должен лежать спокойно.

При постановке банок нужно быть осторожным. Если тампон очень сильно смочен спиртом, то капля горящего спирта может упасть на кожу больного и вызвать ожог. Поэтому, вынимая тампон из спирта, надо стряхнуть его, а затем уже зажечь. Нужно следить за тем, чтобы края банки не очень сильно нагревались, так как это вызывает у больного ожог, а также за тем, чтобы не спалить больному волосы, не поджечь рубашку и пр. Следует избегать накручивать ватный тампон на деревянную палочку, так как она около основания тампона может незаметно перегореть и тогда горящий тампон упадет на кожу больного.

Благодаря получающемуся в банке отрицательному давлению к ней всасывается в банку, кровеносные сосуды. В данном месте расширяются, получается прилив крови к коже и кожа краснеет. От быстрого прилива крови происходит не только расширение кровеносных сосудов, но и разрыв капилляров. На коже образуются точечные кровоизлияния, а иногда и небольшие пузырьки, наполненные жидкостью, выступившей из кровеносных сосудов. Банки обыкновенно держат в течение 10—15 минут, затем осторожно снимают; при этом одной рукой банку слегка отклоняют в сторону, а с противоположной стороны около самого края ее нажимают на кожу пальцем, чтобы в банку вошел воздух — тогда банка сама отпадает.

**БИОПСИЯ** (прижизненное вырезание кусочка ткани для микроскопического исследования). Производится в случаях, когда обычными методами нельзя установить диагноз, чаще всего при подозрении на злокачественное образование. Биопсия производится асептически, обязательно в стационаре. Больного укладывают на операционный стол. Руки хирурга и операционное поле тщательно обеззараживают спиртом и йодом. Из пораженной ткани вместе с частью соседней здоровой скальпелем вырезается клиновидный кусочек, который фиксируется в спирту или формалине и направляется на микроскопическое исследование. Кровотечение из ранки останавливается наложением одного-двух швов. После биопсии через 2—3 дня больной может быть выписан домой.

**БУЖИРОВАНИЕ.** Применяется для расширения суженного пищевода или мочеиспускательного канала. Сужение развивается после воспалительных процессов (или ожогов) с последующим образованием соединительной ткани и рубцов, а также вследствие сдавления опухоли.

Для бужирования уретры (мочеиспускательного канала) употребляются твердые металлические или мягкие эластические бужи различного диаметра. Самый тонкий буж в диаметре имеет 1 мм, каждый следующий на  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{2}{3}$  или  $\frac{1}{2}$  мм толще; самый толстый — 1 см. Начинают бужирование с самого тонкого бужа. Буж оставляют в канале 20—25 минут, затем его удаляют и вводят следующий номер. Бужирование проводят ежедневно, постепенно увеличивая толщину бужа. Бужирование следует производить стерильными бужами, которые предварительно обливают стерильным растительным маслом или глицерином.

Для бужирования пищевода применяют полутвердые эластические (гибкие) бужи длиной 60—100 см и толщиной 0,5—1,5 см или гибкие металлические бужи, состоящие из гибкого металлического

стержня, на конец которого навинчиваются металлические оливы разного калибра. Начинают с наиболее тонкого бужа, а затем постепенно переходят к следующим номерам.

**ВАННЫ ВОДЯНЫЕ.** В а н н а г и г и е н и ч е с к а я . Приготавливается для мытья больного; температура воды 36—37°. На ванну взрослого идет в среднем 25—30 ведер, или 250—200 л воды. Если позволяет состояние больного, он моется сам; слабых больных моет ванщица. Больного необходимо тщательно вымыть мочалкой с мылом, причем особое внимание нужно обращать на складки тела, где задерживается больше пота и грязи (подмышечные впадины, паховая область, пальцы ног, грудные железы полных женщин, половые органы и задний проход), а также на части тела, покрытые волосами, где могут находиться насекомые. Для слабых больных готовят иногда так называемую полуванну, т. е. наливают столько воды, чтобы она покрывала только ноги и низ живота. Ванщица моет все тело больного, а затем обливает его чистой водой.

**В а н н а л е ч е б н а я м е с т н а я .** Если нужно воздействовать на какую-либо часть тела, пользуются местными ваннами. К ним относятся сидячие, ручные, ножные и другие ванны. Местные ванны можно делать более низкой и более высокой температуры и продолжительнее, чем общие ванны. Для местных ванн изготавливается соответствующая посуда. В сидячей ванне вода покрывает таз, нижнюю часть живота до пупка и верхнюю часть бедер. Ручные ванны можно делать в любой посуде, в которой вода покрывает руку: в тазу, лоханке, миске и пр. Для ножных ванн пользуются специальными высокими ваннами в виде удлиненного ведра. Для нижней части голени и для стопы можно пользоваться любой домашней посудой.

В местные ванны прибавляют те или другие лекарственные вещества: горчица, соль (см. *Ванны лекарственные*), марганцовокислый калий и др.

**В а н н а л е ч е б н а я о б щ а я .** По температуре различают холодные ванны — ниже 20°, прохладные — 20—34°, и н д и ф е р е н т н ы е (безразличные) — 35—36°, теплые — 36—38°, горячие — 38—42°. Ванна должна быть наполнена водой прежде, чем в нее будет посажен больной. Чтобы не выделялось много пара, наливают сначала холодную воду, а затем горячую. Во время наполнения ванны водой ее размешивают, чтобы вода была всюду одинаковой температуры; для измерения температуры воды в ванне пользуются специальным водяным термометром в деревянной оправе, чтобы он не тонул и не разбился о дно ванны. Определять температуру по водяному термометру нужно, не вынимая его из воды. В среднем больной находится в ванне 10—20 минут, в холодной — 3—5 минут. При горячей ванне на голову кладут холодный компресс или резиновый мешок со льдом.

**ВАННЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ.** Г о р ч и ч н ы е в а н н ы . Сухую горчицу 250—400 г (на взрослого человека) в марлевом мешочке кладут в теплую ванну и отжимают ее. Ванны делают теплые. Больных держат в ванне до покраснения кожи, в среднем 5—15 минут. Ванну покрывают простыней или, еще лучше, одеялом, остав-

ляя свободной только голову больного, чтобы пары горчицы не раздражали слизистую оболочку глаз и верхние дыхательные пути. После ванны больного нужно облить теплой водой, чтобы смыть с кожи частицы горчицы, а затем насухо вытереть теплой простыней и укутать теплым одеялом.

**К р а х м а л ь н ы е в а н н ы .** Крахмал от 0,5 до 1 кг разводят в холодной воде, затем растворяют в теплой и вливают в ванну. В теплой крахмальной ванне больной может находиться 30—60 минут и даже больше. После ванны больного следует обмыть теплой водой.

**С о л е н ы е в а н н ы .** На ванну для взрослого кладут от 2 до 8 кг поваренной или морской соли. Температура ванны 36—38°. Продолжительность 10—20 минут. После ванны облить больного теплой водой и насухо вытереть.

**В а н н ы с о т р у б я м и .** Отруби пшеничные или миндальные кладут в мешочек из тонкой неплотной материи (марлевой), отваривают с 1—2 л воды; полученный отвар вливают в ванну, туда же кладут мешочек с отрубями. С отрубями готовят теплые ванны.

**Х в о й н ы е в а н н ы .** На ванну употребляют 50 г соснового экстракта. Часто экстракт разводят в соленой ванне (солено-хвойная ванна). Хвойные ванны теплые. Продолжительность пребывания в ванне 15—30 минут.

**ВЕНЕПУНКЦИЯ.** Кровь обычно берут из вен предплечья, в локтевом сгибе. Иглу нужно брать потолще; через тонкую иглу вязкая кровь может не пойти или свернуться внутри нее. Стерилизацию инструментов, кожи больного и рук персонала нужно производить особенно тщательно (см. *Впрыскивания подкожные*). Кожу локтевого сгиба протирают спиртом и эфиром. Если для дезинфекции кожи употребляют йод, то потом это место обтирают эфиром, который растворяет йод (через кожу, смазанную йодом, плохо видны вены). Затем на плечо накладывают резиновый жгут или простую резиновую трубку, чтобы были сдавлены только вены. Правильность наложения жгута проверить по пульсу: если пульс прощупывается, значит артерии не сжаты. Если во время взятия крови больной сидит на стуле, то он кладет на стол обнаженную вытянутую руку, совершенно разогнутую в локтевом сгибе; в постели больной лежит на спине и ему подкладывают под локтевой сгиб подушку, чтобы рука была разогнута. Под руку подкладывают клеенку, чтобы не запачкать белья кровью.

Иглу берут правой рукой большим и указательным пальцем за канюлю; левой рукой фиксируют вену; которая под кожей легко перемещается. Прокол нужно делать под острым углом, чтобы проколоть кожу и переднюю стенку вены; затем ее надо немного продвинуть почти параллельно коже. Удобнее иглу вводить отверстием вверх. Если еще нет достаточного опыта, чтобы не проколоть противоположной стенки, следует вводить иглу отверстием книзу. Вытекающая из иглы кровь говорит о том, что игла находится в вене. На всякий случай всегда должен быть приготовлен стерильный шприц, подходящий к данной игле. Иногда слишком вязкая кровь выходит в недостаточном количестве. Тогда, не вынимая иглы, осторожно надевают на нее шприц,

которым вытягивают кровь из вены. Если кровь берут для исследования, то шприц должен быть сухим, так как в мокром шприце произойдет частичный гемолиз (растворение эритроцитов). После взятия нужного количества крови сначала распускают жгут, затем вынимают из вены иглу, смазывают ранку йодом и заклеивают ее ваткой с коллодием или клеолом.

**ВЕНЕСЕКЦИЯ** (вскрытие вены). Производится в том случае, если периферические вены предплечья плохо выражены и нельзя венепункцией извлечь нужное количество крови. Подготовка к венесекции та же, что и к венепункции. Затем скальпелем (после анестезии новокаином) делают разрез кожи, обнажают вену, вскрывают ее продольным разрезом, вставляют в разрез канюлю. После окончания операции перевязывают вену и на кожу накладывают два-три шва (скобки).

**ВЛИВАНИЯ ВНУТРИВЕННЫЕ.** Техника та же, что и при венепункции, однако игла берется более тонкая. В шприц набирают нужное количество лекарства, выпускают из шприца попавший туда воздух и вводят иглу, надетую на шприц, в вену. Прежде чем набирать раствор в шприц, нужно, чтобы помогающая сестра еще раз вслух прочитала написанное на пузырьке или ампуле название лекарства и его дозировку. Если лекарство находится не в ампуле, то на флаконе обязательно должно быть написано, что оно с т е р и л ь н о . После этого производящий вливание врач или фельдшер должен вслух прочитать то же самое. В некоторых случаях, чтобы не травмировать психику больного, читать нужно настолько тихо, чтобы больной этого не слышал. Соблюдение этого правила гарантирует от роковых ошибок вливания в вену другого лекарства, в том числе и смертельного яда. Если игла находится в вене, кровь начинает поступать в шприц. Помогающая сестра распускает жгут, а производящий вливание, постепенно надавливая поршень большим пальцем правой руки, вводит лекарство в вену. Если нужно ввести большое количество жидкости, вливания производят с помощью аппарата Боброва. После вливания иглу вынимают и обрабатывают ранку (см. *Венепункция*).

Вливания внутривенные капельные производятся либо специальным прибором, либо из кружки Эсмарха, либо из аппарата Боброва.

В середине резиновой трубки, идущей из сосуда к игле, устанавливается капельница (трубка, в которую входит стеклянная трубочка с узким отверстием, пропускающим жидкость только по каплям), а выше ее — винтовой зажим Мора, регулирующий поступление жидкости в капельницу. В остальном — обычная техника (см. *Вливания внутривенные*).

Все составные части прибора (кружка, резиновая и стеклянная трубки, капельница, игла) должны быть стерильны. Для подогревания жидкости аппараты ставят в горячую воду или к ним привязывают грелки с горячей водой, которую меняют по мере остывания.

Капельные вливания обычно продолжают, поэтому трубка, на которую надета игла, фиксируется к предплечью (липким пластырем, бинтом, клеолом), а рука, в которую производят вливание,

1» разогнутая в локтевом

сгибе, подбинтовывается вместе с трубкой к гипсовой лонгете или проволочной шине.

**ВЛИВАНИЯ ПОДКОЖНЫЕ.** Для подкожных вливаний пользуются аппаратом Боброва. Аппарат Боброва, а также жидкость, находящаяся в нем, должны быть стерильны. Наполненный аппарат перед употреблением ставят в горячую воду для согревания. **Жич**-кость для вливания должна иметь температуру приблизительно 40°.

Если в аппарате нет термометра, то температуру жидкости определяют приблизительно, пуская струю воды из аппарата на тыльную поверхность кисти руки. Стерилизация кожи больного и рук оперирующего производится так же, как и при подкожных впрыскиваниях. Перед самым вливанием открывают зажим Мора и выпускают из трубки воздух, а затем вкалывают иглу под кожу на глубину 3—4 см. Накачивать воздух нужно постепенно, не слишком повышая давление воздуха и аппарата. Лучше аппарат установить приблизительно на 1 м выше места вливания, чтобы жидкость автоматически вливалась постепенно под кожу без всякого накачивания. В таком случае 1 л жидкости вводится под кожу приблизительно в течение 30 минут. При вливании можно слегка массировать кожу, под которую вливается жидкость. По окончании вливания иглу быстро вынимают, ранку смазывают йодом и закрывают ваткой, смоченной коллодием. После вливания на место, куда производилось вливание, кладут грелку, чтобы влитая жидкость лучше рассасывалась и уменьшалась боль, которая обыкновенно ощущается во время вливания и после него. Подкожные вливания обыкновенно производят в переднюю часть бедра, в подкожную клетчатку живота, у женщин — под грудные железы.

**ВПРЫСКИВАНИЯ (инъекции) ВНУТРИВЕННЫЕ** см. *Вливания внутривенные*.

**ВПРЫСКИВАНИЯ (инъекции) ВНУТРИКОЖНЫЕ.** Лекарственное вещество острой тонкой иглой впрыскивается в толщу кожи (не прокалывая ее насквозь). Иглу нужно вкалывать под острым углом, проникая только под роговой слой кожи, и затем продвигать иглу в этом слое. При впрыскивании эпидермис приподнимается в виде небольших волдырей. На месте инъекции образуется небольшой белый волдырь, который не следует массировать. После извлечения иглы на место укола не должно появиться ни капли крови. Стерилизация инструментов, обработка кожи больного и рук — те же, что и при подкожных впрыскиваниях.

**ВПРЫСКИВАНИЯ (инъекции) ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ.** Иглы для внутримышечного впрыскивания следует брать длинные (8—10 см), так как они должны проникнуть в толщу мышцы. Наиболее удобным местом для инъекций являются ягодичные мышцы. Больной ложится на живот. Производящий впрыскивание мысленно делит ягодичные мышцы вертикальной и поперечной линией на четыре части. Укол делается в верхний наружный квадрант, где не проходят крупные кровеносные сосуды и важные нервные стволы. В следующий раз инъекцию производят в другую ягодичку. В правую руку берут шприц за нижнюю часть около иглы, большим и указательным пальцем левой руки прижимают и натягивают кожу на месте укола. Можно мягкие части ягодички (кожу вместе с мышцами)

захватить левой рукой в большую складку. Иглу быстро вкалывают перпендикулярно к поверхности ягодицы на глубину 5—6 см, а затем большим пальцем правой руки медленно выжимают жидкость из шприца в мышцу. Лекарственная жидкость должна быть теплой. Стерилизация инструментов, обработка кожи и рук — те же, что и при подкожных впрыскиваниях.

**ВПРЫСКИВАНИЯ (инъекции) ПОДКОЖНЫЕ.** Инструменты стерилизуют кипячением. Кипятить шприц нужно в разобранном виде; чтобы отдельные части шприца во время кипячения не соприкасались, рекомендуется обертывать их слоем марли. При кипячении шприц опускают сначала в теплую воду, чтобы стеклянные части не лопнули. Кипятить инструменты следует 15—20 минут. Кожа больного должна быть совершенно чистой, для чего ее протирают спиртом. После повторного протирания спиртом ватка должна оставаться абсолютно чистой, что является показателем достаточной чистоты кожи. Если кожа была значительно загрязнена, то ее предварительно следует вымыть с мылом. Вместо протирания спиртом можно место укола смазать йодом. Перед инъекцией моют руки в теплой воде с мылом и щеткой, а затем протирают их спиртом. Чтобы под ногтями не скопилось грязь и чтобы ее легко было удалять, следует коротко стричь ногти. Лекарственное вещество, которое вводится под кожу, должно быть в запаянных ампулах или на пузырьках обязательно должна быть надпись, что данное лекарство стерильно; в противном случае нельзя делать инъекцию. Места для инъекций нужно выбирать такие, где близко нет артерий, поверхностно расположенных вен и нервных стволов. Лучше всего впрыскивания делать в заднюю поверхность плеча, наружную и переднюю поверхность бедра, под кожу живота, под углом лопатки в межлопаточное пространство или под ключицами. Не следует делать инъекций все время в одно место, чтобы не раздражать кожу. Когда кожа обработана, оставляют ватку с эфиром на месте будущего укола, стерильным пинцетом достают цилиндр шприца, вставляют в него поршень, надевают плотно иглу на наконечник и пинцетом же вынимают из нее мандрен. Притереть иглу к шприцу можно и рукой, держа ее за муфту.

Необходимо всегда помнить, что руки производящего инъекцию хотя и чисты, но не стерильны, — так как для стерилизации нужно их мыть 15 минут. Кроме того, приходится касаться руками и нестерильных предметов: открывать стерилизатор, пузырьки с лекарством, спиртом, эфиром и пр. Чтобы не внести в кровь больного инфекции, нельзя касаться руками стержня иглы, места укола и самого лекарства, брать поршень шприца можно только за рукоятку. Чтобы не впрыснуть больному по ошибке не то лекарство, которое назначено, перед открыванием пузырька или ампулы следует еще раз вслух прочитать написанное на пузырьке или ампуле название лекарства и его дозировку. Перед вскрытием ампулы ее надпиливают специальной пилкой на месте перехода в узкую часть, затем это место протирают ваткой, смоченной в эфире или спирту, после чего этой же ваткой подламывают ампулу. В отверстие опу-

екают иглу шприца и, наклоняя ампулу, постепенно набирают из нее содержимое. После того как в шприц набрана жидкость, его поворачивают иглой вверх и постепенно выпускают пузырьки воздуха, а также излишнюю жидкость, оставляя только необходимое количество. Затем снимают ватку, прикрывающую кожу, захватывают кожу в складку тремя пальцами левой руки и приподнимают ее. Правой рукой берут шприц, приставляют иглу к основанию складки кожи приблизительно под углом в 45°, быстро и уверенно вкалывают иглу в подкожную клетчатку на глубину 1,5—3 см. После этого шприц держат I и III пальцем, а указательным нажимают на поршень и впрыскивают лекарство под кожу. При опасении, что игла во время инъекции может соскочить со шприца, складку кожи распускают и левой рукой придерживают иглу за канюлю. Иногда шприц держат между II и III пальцем и :адавливают на поршень большим пальцем, что часто бывает удобней.

После инъекции иглу быстро извлекают, а место укола прижимают кусочком ваты, смоченной спиртом. Этой же ваткой место укола слегка массируют, чтобы впрыснутая жидкость лучше рассосалась.

**ВТИРАНИЯ.** Втиранием (фрикцией) называется введение лекарственного вещества в организм через здоровую, неповрежденную кожу. Для втирания выбирают места кожи, не покрытые волосами (или их сбривают), а также такие, где кожа тоньше и нежнее: сгибательная поверхность рук и ног, боковые поверхности грудной клетки, живот, внутренняя поверхность бедер. Перед втиранием кожу нужно обмыть с мылом; руки должны быть хорошо вымыты. Пальцами захватывают небольшое количество мази или наливают лекарство на ладонь (если оно жидкое), наносят его на кожу и круговыми и продольными движениями втирают до тех пор, пока оно не втрется в кожу. Такими небольшими порциями производят втирания несколько раз.

Втирания ртутной мази требуют особых предосторожностей, так как ртуть — сильный яд. На каждое втирание берут в среднем 3,0 мази и втирают их полностью в определенный участок кожи. Сначала берут небольшое количество мази и втирают досуха, затем снова берут кусочек, и таким образом втирают всю порцию. Каждое втирание продолжается 30—40 минут. Первый день втирают в одну руку, второй — в другую, затем в бока и в ноги. Так втирают 6 дней; на 7-й день делают ванну, а затем снова начинают втирания в прежнем порядке. Курс лечения в среднем состоит из 30 втираний. Втирая мазь в кожу больного, производящий процедуру частично втирает мазь в свои пальцы и ладони. Поэтому желательно, чтобы больные сами проделывали втирание мазей, подобных серой ртутной.

Персонал, производящий ртутные втирания, должен работать в резиновых перчатках или с помощью различных приспособлений в форме пресс-пальца, гриба или пестика, обтянутых замшей или какой-либо плотной тканью. В настоящее время втирания серой ртутной мази редко производятся.

**ГАЗООТВЕДЕНИЕ.** Промывательные- клизмы, клизмы с ромашкой и особенно сифонные клизмы способствуют выведению зна-

чительного количества газов из кишечника. Если эти меры не достигают цели, то в прямую кишку вводят газоотводную трубку, которая представляет собой длинный резиновый наконечник. Его смазывают вазелином и вводят в задний проход на глубину 20—20 см, причем наружу наконечник должен выступать не менее чем на 10 см. Скопившиеся газы находятся в кишечнике под повышенным давлением и поэтому свободно выходят через газоотводную трубку. Ее оставляют в кишечнике на несколько часов. Очень долго оставлять газоотводную трубку нельзя, так как она может вызвать раздражение слизистой оболочки и даже образование пролежней. В случае надобности

^

газоотводную трубку спустя несколько часов можно ввести вновь. Вынимать ее следует осторожно, постепенно. Под конец трубки подкладывают клеенку или полотенце, а в случае надобности кладут ее в стоящее тут же подкладное судно или таз.

**ГОРЧИЧНИКИ.** Горчичники, поступающие в продажу, приготавливают на плотной бумаге длиной 12 см и шириной 8 см, на которую особым составом наносится сухая горчица. Горчичник смачивают теплой водой и плотно прикладывают к коже на 5—10—20 минут, придерживая его рукой или укрепив бинтом. Уже через несколько минут больной ощущает теплоту и небольшое жжение. Горчичник держат до появления красноты кожи, не доводя до ожога и образования пузырей. После снятия горчичника кожу обмывают теплой водой. Горчичники можно готовить самим: сухую горчицу разводят в теплой воде до кашецеобразного состояния; эту кашку намазывают на тряпочку, сверху ее тоже прикрывают тряпочкой и прикладывают к телу. Чтобы горчичник не очень раздражал кожу и его можно было дольше держать, сухую горчицу предварительно смешивают с равным количеством муки. Для детей иногда готовят горчичники, беря муки в 2—3 раза больше, чем горчицы.

**ГРЕЛКИ.** Полностью грелку не наполняют водой, чтобы она не была тяжелой. Оставшийся воздух из резиновой грелки осторожно выжимают. Грелку следует плотно завинчивать, чтобы не облить больного горячей водой. Если нет грелок, можно пользоваться бутылками с горячей водой. Нужно только следить за тем, чтобы бутылки плотно закрывались пробками. Перед тем как поставить грелки или бутылки с горячей водой, нужно обязательно повернуть их вниз пробкой, чтобы проверить, не подтекают ли они. Прежде чем приложить грелку, ее покрывают полотенцем. Очень горячую грелку кладут сначала на одеяло, а затем по мере ее остывания — под одеяло.

Слабые и тяжело больные не всегда быстро реагируют на раздражение, поэтому у них грелками можно вызвать ожоги. Особенно осторожным нужно быть с больными, находящимися в бессознательном состоянии и утратившими кожную чувствительность: им нельзя ставить очень горячие грелки или класть грелки непосредственно на тело; кроме того, следует периодически проверять, не слишком ли грелки согревают кожу.

**ДЫХАНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ** см. *Искусственное дыхание.*

**ЖЕЛУДКА ПРОМЫВАНИЕ** см. *Промывание желудка.*

**ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ИЗВЛЕЧЕНИЕ** см. *Зондирование желудка.*

**ЗОНДИРОВАНИЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ТОНКИМ ЗОНДОМ.** Тонкий (дуоденальный) зонд представляет собой мягкую резиновую трубку толщиной 3—5 мм и длиной 1,5 м, на конце которой находится металлическая или костяная олива с несколькими отверстиями. Олива обыкновенно состоит из двух свинчивающихся половин, чтобы ее легко было очистить. Зонд имеет три метки: первая на расстоянии 50 см от оливы, что соответствует расстоянию от зубов до входа в желудок; вторая — на расстоянии 70 см, что соответствует входу в привратник; третья — на расстоянии 90 см от оливы — расстояние, достаточное для того, чтобы зонд попал в двенадцатиперстную кишку. Для отсасывания дуоденального содержимого пользуются обычным 10- или 20-граммовым шприцем.

Тонкий зонд необходимо вводить натошак. Больного сажают на стул, вводят теплый влажный зонд в глотку и предлагают больному сделать глотательные движения. Как только зонд попал в пищевод, благодаря перистальтике последнего, он продвигается дальше без всяких усилий. Иногда больному приходится делать повторные глотательные и сосательные движения. Если у больного имеются зубные протезы, их надо перед исследованием снять. Когда олива проникла в желудок, т. е. зонд вошел до первой метки, необходимо отсосать желудочное содержимое. Если ничего не отсасывается, нужно продвинуть зонд дальше или несколько вытянуть обратно. Чтобы дуоденальный зонд прошел в двенадцатиперстную кишку, исследуемого кладут на правый бок, приподняв таз. Благодаря желудочной перистальтике и тяжести оливы, она постепенно продвигается к привратнику. В течение всего исследования больной должен помогать продвижению зонда, всасывая и заглатывая его. Если зонд дошел до третьей метки, следует удостовериться, находится ли он в двенадцатиперстной кишке. Дуоденальное содержимое отличается от желудочного: дуоденальный сок зеленовато-желтого цвета, прозрачный, щелочной реакции, а желудочный — беловатый или бесцветный, реакция его кислая. Если желчь забрасывается из двенадцатиперстной кишки в желудок, то желудочный сок тоже будет желтого цвета, но в отличие от дуоденального он будет мутным. У постели больного устанавливают штатив с чистыми пробирками, куда и собирают содержимое двенадцатиперстной кишки.

Первое прозрачное желтое содержимое двенадцатиперстной кишки, полученное при откачивании, называют порцией А. Если нужно получить пузырную желчь, то шприцем через зонд впрыскивают в двенадцатиперстную кишку 50 мл 25% раствора сернокислой магнезии, благодаря которой сфинктер желчного пузыря расслабляется (рефлекторно) и пузырная желчь поступает в двенадцатиперстную кишку. Пузырная желчь темнокоричневого цвета, ее называют второй порцией, или порцией В. После откачивания всей пузырной желчи снова появляется светлая желчь. Третья порция, печечная желчь, называется порцией С.

**ЗОНДИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА ТОЛСТЫМ ЗОНДОМ.** Толстый (желудочный) зонд представляет собой резиновую трубку из довольно плотной резины длиной 75 см, имеющую в диаметре 8—12 мм.

На закругленном конце зонда, который вводят в желудок, по сторонам находятся два овальных отверстия, расположенных одно над другим; на другом конце зонда имеется небольшое воронкообразное расширение. На расстоянии 40 см от желудочного конца зонда делается метка: у большинства людей вход в желудок расположен на расстоянии 40—50 см от переднего края зубов. Перед исследованием желудочный зонд кипятят и проверяют, насколько хорошо он пропускает воду. Больного сажают на стул, на спинку которого он может облокотиться, надевают на него клеенчатый фартук или закрывают его простыней до шеи; другой конец фартука должен быть опущен в таз, который ставят на пол между ногами больного. Для собирания желудочного содержимого берут чистый стеклянный стакан, цилиндр или банку, в которую опускают широкий копец зонда. Во время процедуры больной должен свободно дышать через нос, не закидывать голову назад, не закусывать зонд и не хватать его руками. Если у больного имеются зубные протезы, то перед введением зонда их обязательно нужно вынуть. Производящий зондирование становится по правую сторону больного, а помощник — по левую.

Для введения зонда берут его правой рукой, отступая от желудочного конца на 10—15 см, быстро вводят в рот до корня языка и предлагают больному сделать глотательное движение, после чего зонд поступает в пищевод и легко проходит в желудок. Вводят зонд или одной правой рукой, или попеременно обеими руками. Часто больной вместо глотательного движения производит рефлекторное рвотное движение, стараясь выбросить зонд из глотки; в этих случаях не следует насильно проталкивать зонд вперед, надо его вынуть и затем снова ввести. Можно дать больному выпить воды и во время ее проглатывания быстро протолкнуть зонд вперед. Иногда лучше не предлагать больному делать глотательных движений, а самому быстро ввести зонд. Введение зонда до метки показывает, что он попал в желудок. Желудочное содержимое иногда без всяких усилий со стороны больного вытекает через зонд. В большинстве случаев для получения всего количества желудочного содержимого приходится просить больного произвести несколько рвотных движений. Если желудочное содержимое не выделяется, то зонд вводят несколько дальше метки, заставляют больного кашлять, тужиться, надавливают ему на подложечную область. После всех этих манипуляций, удостоверившись, что желудок пуст, зонд быстро вынимают из желудка.

Если нужно исследовать желудочный сок, то натощак дают пробный завтрак. Наиболее часто применяется пробный завтрак Боас-Эвальда, который состоит из 50 г сухого белого хлеба и 400 мл (двух стаканов) теплой воды или жидкого чая без сахара. Больной должен медленно разжевывать хлеб, запивая водой; через 45 минут после окончания пробного завтрака вводят зонд для получения желудочного сока.

**ЗОНДИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА ТОНКИМ ЗОНДОМ.** Тонкий зонд вводят в желудок так же, как и при зондировании двенадцатиперстной кишки (см.). Когда зонд уже находится в желудке, конец его прикрепляют английской булавкой или зажимом к ру-

башке больного, чтобы он не прошел в двенадцатиперстную кишку. Конец зонда лучше всего закрывать зажимом Мора, чтобы желудочное содержимое не вытекало самопроизвольно. При помощи тонкого зонда можно через произвольные промежутки времени отсасывать шприцем желудочное содержимое в нужном количестве в течение всего времени нахождения зонда в желудке. Таким путем можно определить сокоотделительную функцию желудочных желез в разное время после приема пробного завтрака, а также более точно установить моторную (двигательную) функцию желудка. В этих случаях применяют только жидкие пробные завтраки, например, бульонный, капустный и др. Пробный завтрак Зимницкого состоит из крепкого бульона. Бульон готовят из 400 г говяжьей мякоти без жира на 1 л воды. Варят мясо пока останется 400 мл бульона; его дают в два приема по 200 мл на прием.

Больному натощак вводят в желудок тонкий зонд и откачивают полностью находящийся там желудочный сок. Не вынимая зонда, вводят через него 200 мл теплого бульона. Каждые 15 минут откачивают шприцем по 10—15 мл содержимого, а через 60 минут — все остальное. Затем снова вливают в желудок 200 мл бульона и вновь откачивают четыре порции желудочного содержимого. Все полученные порции посылают в лабораторию для исследования. Пробный завтрак Лепорского состоит из капустного сока: кочан капусты пропускают через мясорубку, сок отжимают через марлю, кипятят и затем фильтруют через вату.

**ИНГАЛЯЦИЯ.** Вдыхание с лечебными целями паров, газов или мелко распыленных капелек лекарственной жидкости при помощи ингалятора. Резервуар ингалятора наполовину наполняют водой; под резервуаром зажигают спиртовку. Стаканчик наполняют раствором лекарственного вещества. Водяные пары, идущие под значительным давлением из резервуара, вызывают разрежение воздуха, вследствие чего жидкость из стаканчика поднимается вверх; под действием струи пара она распыляется и вместе с паром увлекается в трубку, перед которой сидит больной и вдыхает пар вместе с распыленным лекарственным веществом. Ингаляцию производят обыкновенно в течение нескольких минут, пока не испарится жидкость из стаканчика, 1—2 раза в день. В случае надобности стаканчик повторно наполняют лекарственным раствором. Шею и грудь больного во время ингаляции закрывают полотенцем, чтобы не замочить рубашку или платье. После ингаляции больной не должен в течение 15—20 минут разговаривать и выходить на холодный воздух, чтобы не раздражать голосовые связки и дыхательные пути. В специальных лечебных учреждениях и на курортах применяют не индивидуальные ингаляторы, а устраивают специальные комнаты, в воздухе которых распылено лекарственное вещество. Больные сидят или лежат и в течение определенного времени дышат воздухом этого помещения.

Иногда применяют примитивный (домашний) способ: кипятят воду в чайнике, кладут в нее лекарственное вещество, и больной вдыхает водяные пары над открытым чайником.

**ИНТУБАЦИЯ.** Введение особой трубочки в гортань через рот. Применяется при дифтерии, ложном крупе или отеке, когда суже-

ние гортани бывает настолько значительным, что больной может погибнуть от асфиксии (задушения). Интубационная трубочка вводится при помощи особого инструмента — интубатора, имеющего вид изогнутого пинцета с раздвижными брашнями. Предварительно к интубационной трубочке привязывают шелковую нитку, с помощью которой трубка извлекается из гортани. Перед введением интубатора инструменты должны быть прокипятированы и тщательно осмотрены. Взрослого больного сажают на стул, предлагают ему подложить под себя кисти рук, опереться на спинку стула и не закидывать голову; спереди больного закрывают простыней. Ребенку можно произвести интубацию только с одним или даже с двумя помощниками. Помощник садится на стул, сажает ребенка к себе на колени, руки ребенка предварительно пеленают, а ноги зажимают между коленями. Одной рукой помощник прижимает ребенка плотно к груди, а другой держит его голову, наклонив немного вперед, причем ее ни в коем случае нельзя закидывать назад. Оказывающий помощь садится против больного, вводит в рот ротаторасширитель, затем вводит левый указательный палец глубоко в рот до гортани, прижимает надгортанник кпереди к корню языка, а сзади ощупывает черпаловидные хрящи и заднюю стенку гортани. После этого по наружному краю левого указательного пальца правой рукой подводится к гортани при помощи интубатора интубационная трубочка. Затем приподнимают рукоятку интубатора и указательным пальцем направляют трубочку в просвет гортани, чтобы она не попала в пищевод. Когда трубка упрется в голосовые связки, надо произвести легкое надавливание, тогда во время вдоха трубочка пройдет через голосовую щель. Брашнии интубатора сдвигают и трубочку легко погружают пальцем в гортань как можно глубже. О том, что трубочка введена правильно, судят по появившемуся металлическому (трубочному) звуку дыхания. Шелковинку, идущую от трубочки, липким пластырем прикрепляют к щеке больного. Во избежание пролежней в гортани трубочку приходится удалять через 24—36 часов. Больной с введенной интубационной трубкой должен непрерывно находиться под наблюдением, так как трубка при кашле или рвоте может выскочить из гортани, а ребенок может выдернуть ее за шелковинку. **ИНЪЕКЦИИ** см. *Впрыскивания*.

**ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ.** Прежде чем приступить к искусственному дыханию, нужно освободить пострадавшего от стесняющей его одежды: расстегнуть воротник, снять пояс, ремень, лифчик, распушить тесемки, расстегнуть брюки и пр.; затем освободить полость рта от всяких инородных предметов, в том числе зубных протезов, очистить рот от грязи, слизи, земли и пр., введя глубоко в полость рта палец, обернутый марлей или полотенцем. Если у пострадавшего тесно сжаты челюсти, то приходится их с силой разомкнуть. Для этого вводят ротаторасширитель в сомкнутом виде в угол рта за коренными зубами. При сжимании ручек ротаторасширителя расходятся его концы, которые при сжатии челюстей не могут сомкнуться благодаря имеющемуся замку; чтобы вынуть ротаторасширитель, зубцы замка сдвигают со штифта, и концы спадаются. За неимением ротаторасширителя можно пользоваться

шпатель, ложкой, деревянной палочкой и пр. Если язык запал в глотку, нужно выдвинуть вперед нижнюю челюсть так, чтобы нижние зубы выступали впереди верхних. В некоторых случаях приходится языкодержателем вытягивать язык изо рта и так держать его во время искусственного дыхания. За неимением языкодержателя язык можно держать куском марли, носовым платком или полотенцем.

Искусственное дыхание нужно производить терпеливо и спокойно в течение долгого времени, до появления совершенно нормального дыхания или, в случае отсутствия дыхания, до появления трупных пятен (по инструкции Министерства здравоохранения СССР).

**Способ Сильвестра** применяется наиболее часто. Пострадавшего кладут на спину, под нижнюю часть грудной клетки подкладывают валик из сложенного одеяла, шинели или просто полено, чтобы лопатки и затылок лежали ниже реберных дуг. Если искусственное дыхание производят два лица, то они становятся на колени по обе стороны грудной клетки пострадавшего. Каждый из них берет одной рукой руку пострадавшего посередине плеча, а другой — несколько выше кисти. Одновременно они поднимают руки пострадавшего и вытягивают их за его головой. От этого происходит расширение грудной клетки, что соответствует вдоху. Затем через 2—3 секунды прижимают руки пострадавшего к грудной клетке и сдавливают ее, что соответствует выдоху. Движения руками нужно производить ритмично с правильными промежутками времени. Чтобы эти движения соответствовали нормальному дыханию, самое лучшее — когда производящие искусственное дыхание приравниваются к своему собственному дыханию. Такие движения производятся примерно 16 раз в минуту. Если искусственное дыхание производит один человек, он становится на колени за головой пострадавшего, берет его руки выше кистей и производит такие же движения.

**Способ Шеффера.** Если руки пострадавшего повреждены, то искусственное дыхание можно производить по способу Шеффера. Для этого пострадавшего кладут плашмя на живот, голову поворачивают в сторону, чтобы он мог свободно дышать. Производящий искусственное дыхание становится на колени так, чтобы тело пострадавшего было между его ногами, кладет руки на нижнюю часть грудной клетки, чтобы большие пальцы располагались вдоль позвоночника, а остальные на ребрах. Во время выдоха нужно наклоняться вперед и сжимать грудную клетку, а во время вдоха выпрямляться и прекращать давление.

**Способ Лабора** заключается в том, что захватывают язык пострадавшего и производят ритмические вытягивания соответственно дыхательным движениям. Этим способом пользуются, когда дыхание только что остановилось, например, при даче наркоза. Обычно этот способ является дополнительным к способам, указанным выше.

**Способ Каллистова** прост и эффективен. Пострадавшего кладут на живот, лицом вниз. На спину в области лопаток накладывают полотенце, концы его проводят через подмышечные впадины вперед. Оказывающий помощь берет полотенце за концы



и приподнимает туловище от земли на 7—10 см. Происходит расширение грудной клетки и поднятие ребер. Приподнимание туловища соответствует вдоху, а последующее опускание — выдоху. Вместо полотенца можно пользоваться ремнем, шарфом, бинтами и пр.

**КАТЕТЕРИЗАЦИЯ.** Катетеры бывают мягкие (резиновые) и твердые (металлические). Мягкий катетер (катетер Нелатона) делают из плотной резины длиной 25—30 см. Внутренний конец катетера закруглен, сбоку от него имеется одно или два овальных отверстия. Наружный конец несколько расширен наподобие воронки. Диаметр катетеров очень разнообразен — от  $\frac{1}{3}$  мм до 1 см. Различают 30 номеров катетеров. При сужениях мочеиспускательного канала употребляют катетеры более мелкого калибра. Если мочеиспускательный канал не сужен и не болезнен, употребляют средние номера катетеров (№ 14—18). Чтобы не внести инфекции в мочеиспускательный канал или мочевой пузырь, катетеры стерилизуют кипячением. Руки моют, как для операции (см.), и затем протирают раствором сулемы 1 : 1 000 и спиртом. Больной во время катетеризации лежит на спине, между ногами кладут утку, лоточек или мочевую кружку, куда по катетеру стекает моча. Фельдшер берет в левую руку половой член и открывает его головку. Головку члена тщательно протирают ваткой, смоченной раствором сулемы или борной кислоты. Правой рукой вводят постепенно, с небольшим насилием катетер, предварительно политый стерильным растительным маслом (прованским, подсолнечным), вазелиновым или глицерином. Наружный конец катетера предварительно опускают в сосуд, куда должна стекать моча. Если руки нестерильны, то нельзя касаться руками той части катетера, которая соприкасается со слизистой оболочкой мочеиспускательного канала. Катетер продвигается пинцетом, который держат большим и указательным пальцем; наружный конец катетера зажимается между IV и V пальцем.

Катетеризация у женщин производится при соблюдении тех же правил асептики следующим образом. Вольная лежит на гинекологическом кресле или на кровати со слегка согнутыми\* в коленных суставах, подведенными к животу и разведенными в стороны ногами.левой рукой раздвигают половые губы, а правой — сверху вниз (в сторону заднего прохода) тщательно протирают вульву ваткой, смоченной в растворе сулемы 1 : 1 000. Бросив вату, правой же рукой пинцетом берут женский металлический катетер, облитый вазелиновым или каким-либо другим маслом, и, найдя наружное отверстие мочеиспускательного канала, осторожно вводят его. Сосуд, куда должна стекать моча (подкладное судно, стакан), должен быть приготовлен заранее. Когда моча перестает самостоятельно выходить, можно слегка надавить через брюшные стенки на область мочевого пузыря для выведения из него остаточной мочи, а затем уже медленно извлекать катетер.

**КЛИЗМА.** Аппарат для введения клизмы состоит из кружки, в которую наливают воду, резиновой трубки и наконечника.

Кружка емкостью 1—1,5 л бывает стеклянной, металлической и резиновой. Резиновая трубка длиной прибли-

тельно 1,5 м одним концом надевается на суженную выходную часть кружки, а другим — на закругленный конец крана, который соединяется с наконечником. Если крана не имеется, резиновую трубку непосредственно соединяют с наконечником и около наконечника на трубку накладывают зажим. Чаще всего употребляют твердые каучуковые или мягкие резиновые наконечники, иногда пользуются стеклянными наконечниками, которые очень удобны для дезинфекции; однако с ними следует обращаться очень осторожно, чтобы при введении в прямую кишку не сломать их и не поранить кишки. Мягкие наконечники вводить в прямую кишку труднее, ими приходится пользоваться в тех случаях, когда твердые наконечники раздражают слизистую оболочку и вызывают болевые ощущения. Для промывательной клизмы в кружку обыкновенно наливают от 4 до 6 стаканов чистой теплой (25—35°) воды (от 800 до 1 200 мл, в среднем 1 000 мл). Наполнив кружку водой, открывают кран или зажим, чтобы наполнить трубку водой и выпустить из нее воздух. Из кружки спускают немного воды и кран снова закрывают. Кружку обычно поднимают на высоту 0,5—1,5 м над уровнем кровати и укрепляют на соответствующей высоте. Чем выше поднята кружка, тем под большим давлением вода поступает в кишечник. Больного кладут на левый бок близ края постели с пригнутыми к животу ногами. Под таз больного подкладывают клеенку, которую спускают в рядом стоящее ведро на случай, если больной не сможет удержать воду и выпустит ее обратно. Наконечник смазывают вазелином или глицерином. Пальцами левой руки раздвигают ягодицы, а правой рукой осторожно вводят наконечник в прямую кишку на 6—8 см. Чтобы не упираться в слизистую оболочку кишки и не раздражать ее, нужно вводить наконечник по ходу прямой кишки: первые 3—4 см нужно вводить наконечник вверх и вперед по линии, соединяющей задний проход с пупком, а затем повернуть наконечник кзади. Когда наконечник введен на требуемую глубину, открывают кран или зажим, и вода в силу своей тяжести сама вливается в кишечник. Когда вся вода из кружки прошла в трубку, кран закрывают и наконечник вынимают. У больного во время введения воды в кишечник, а также и по окончании клизмы появляются позывы на дефекацию, а иногда и боли в животе. Однако больной должен потерпеть и постараться задержать воду в кишечнике несколько минут, чтобы она успела омыть весь толстый кишечник и раздробить твердый кал. На это время больного прикрывают одеялом. По окончании процедуры кружку и трубку промывают, особенно тщательно обмывают наконечник, который стерилизуют и хранят в банке с дезинфицирующей жидкостью, например, в растворе сулемы.

Не всегда вода свободно поступает в кишечник, встречая плотные массы кала, заполняющие кишку. В таких случаях вводят наконечник глубже, а кружку поднимают выше, — это так называемая высклизма. В других случаях наконечник следует несколько вывести обратно и впустить воду под небольшим давлением, чтобы она постепенно раздробляла каловые массы.

Иногда наконечник закупоривается плотным калом, тогда следует поднять кружку выше, чтобы протолкнуть кал. Если, несмотря на это, вода все же не поступает в прямую кишку, надо закрыть кран, извлечь наконечник, прочистить его и ввести повторно. Каловые массы могут быть настолько твердыми (каловые камни), что поставить клизму совершенно не удастся. Кал приходится извлекать из прямой кишки пальцем. Для этого надевают резиновую перчатку или резиновый колпачок на указательный палец, смазывают его вазелином или глицерином и извлекают кал кусками, а затем уже ставят клизму. Для лучшего действия к воде иногда прибавляют 2—3 столовых ложки глицерина или растительного масла: касторового, подсолнечного, прованского или сезамового. Масло обволакивает кал и способствует его продвижению по кишечнику. С этой же целью применяют мыльные клизмы. На кружку воды настругивают приблизительно столовую ложку простого стирального мыла и растворяют его так, чтобы не образовывалось пены.

Различные болезни прямой кишки и заднего прохода, при которых введение наконечника резко болезненно, например, трещины около заднего прохода, воспаление слизистой оболочки прямой кишки и др., являются противопоказаниями к постановке клизм. Нельзя также ставить клизмы, когда требуется покой для кишечника, когда вредно всякое его раздражение, при язвенном процессе в кишках, при кишечном кровотечении, остром перитоните, остром аппендиците и после операций в полости живота.

**Капельные клизмы.** Очень медленно, по каплям, вводят в кишечник воду или растворы каких-либо лекарственных веществ с тем, чтобы они всасывались слизистой оболочкой кишечника. Перед капельной клизмой обязательно ставят очистительную клизму (см. *Клизма очистительная*). Капельную клизму делают так же, как и обыкновенную, только берут длинный резиновый наконечник. Кран приоткрывают настолько, чтобы из наконечника вода выходила каплями, после чего наконечник, смазанный вазелином, вставляют глубоко в прямую кишку. Больного покрывают одеялом, так как капельная клизма продолжается иногда несколько часов. Вместо того чтобы регулировать вытекающую жидкость краном, удобнее пользоваться специальной капельницей (см. *Вливания внутривенные капельные*). Конец капельной трубки, в которую впаивают капельница, соединен с резиновой трубкой, идущей от кружки, а другой конец — с трубкой, соединенной с наконечником. Содержимое в кружке надо подогревать, либо подливая в горячем виде соответствующую жидкость, либо привязывая к кружке грелку, либо закутав ее в специальный ватник.

**Лекарственные клизмы.** Применяются с двойной целью: непосредственно воздействовать на слизистую оболочку кишечника или ввести лекарство в организм путем всасывания его стенкой кишечника. Перед каждой лекарственной клизмой следует ставить очистительную.

**Ромашковые клизмы.** Одну-две столовых ложки высушенных цветов ромашки заваривают, как чай; полученный настой процеживают через марлю и вливают в воду для клизмы

Настой ромашки является слабым вяжущим средством, главным образом поглощающим газы кишечника.

**Крахмальные клизмы** (при острых колитах и дизентерии). Столовую ложку крахмала тщательно разводят в полустакане холодной воды, а затем доливают горячей водой до 2—3 стаканов (не больше) и после охлаждения до 40—38° вводят в прямую кишку. Крахмальная клизма действует на воспаленную слизистую оболочку обволакивающим и смягчающим образом. В крахмальную клизму можно добавить различные лекарственные вещества.

**Микроклизмы** из самых разнообразных настоев и растворов. Клизмы делают в 100, 50, 25 мл и менее. Их вводят в прямую кишку при помощи резинового баллона и даже шприца, на конец которого надевают резиновый наконечник. Температура жидкости 35—37°. До введения микроклизмы делают очистительную клизму.

**Питательные клизмы** применяют при невозможности питать больного через рот, например, при заражении пищевода, неукротимой рвоте и пр. Хорошо всасывается в кишечнике раствор глюкозы, алкоголь и до некоторой степени бульон. За один раз можно вводить 100 мл, максимум 200 мл жидкости. За час до введения питательной клизмы нужно поставить очистительную. Содержимое клизмы подогревают до 37—38° и вводят его при помощи резинового баллона. После этого больной должен час лежать неподвижно, чтобы введенная жидкость не вытекла обратно. К питательной клизме иногда прибавляют пепсин с соляной кислотой и препараты поджелудочной железы.

Чтобы ввести в организм больше глюкозы, а одновременно и жидкости, лучше всего применять раствор глюкозы в виде капельных клизм. Кроме того, применяют для питательных клизм 5—10% раствор пептона (продукт распада белка), молоко, разбавленный спирт.

**Примерные прописи питательных клизм:**

Rp. Красное вино 50,0  
Виноградный сахар 20,0  
Вода 50,0  
DS. Питательная клизма

Rp. Бульон 100,0  
Красное вино 50,0  
Поваренная соль 1,5 DS.  
Питательная клизма.

Иногда в питательные клизмы прибавляют желтки и другие пищевые продукты. Это нерационально, так как непереваренные белки, жиры и углеводы из толстого кишечника не всасываются.

**Сифонная клизма.** Многократное промывание кишечника, когда никакие слабительные и клизмы не вызывают опорожнения его или же когда это опорожнение требуется произвести быстро. Вместо кружки берут большую воронку емкостью в 500—1 000 мл, на края надевают длинный (20—30 см) резиновый наконеч-

ник, который вводят глубоко в прямую кишку. Когда наконечник вставлен, воронку держат ниже уровня кровати, наполняют ее водой и затем высоко поднимают. Вода под большим давлением проникает в кишечник. Когда вода доходит до дна воронки, последнюю быстро опускают вниз, вода легко проходит из кишечника обратно в воронку. Нужно внимательно следить, чтобы не вся вода из воронки прошла в кишечник, так как в этом случае значительная часть воды может остаться в кишечнике. Из воронки воду выливают в подставленный таз, снова наполняют воронку водой и таким образом эту процедуру повторяют до пяти и более раз, смотря по надобности.

**КОМПРЕСС СОГРЕВАЮЩИЙ.** Берут кусок полотняной или бумажной материи, сложенной в несколько раз соответственно размерам участка, который должен быть под компрессом, смачивают его в теплой воде, хорошо выжимают и плотно прикладывают к телу. Поверх кладут какой-либо водонепроницаемый материал. Обыкновенно для этого служит специальная мягкая клеенка или вощаная бумага. Клеенка должна быть больше смоченной материи и полностью ее закрывать. Поверх клеенки накладывают довольно толстый слой ваты для сохранения тепла, образующегося под компрессом. Слой ваты должен быть больше клеенки и полностью ее закрывать. Компресс прибинтовывают так, чтобы он плотно прилегал к телу и не сдвигался с места. Однако слишком туго прибинтовывать его не следует, чтобы не стеснять больного. При наложении компресса на грудную клетку делают специальные напечники, чтобы компресс захватил и верхушки легких. Слабому больному компресс надо наложить быстро, поэтому его заранее готовят: раскладывают соответствующей величины слой ваты и на него кладут клеенку, а сверху смоченное и выжатое полотенце. При бинтовании грудной клетки бинт нужно накладывать через надплечья, чтобы компресс не сползал па живот. Иногда согревающий компресс выкраивают в виде жилетки, которую можно быстро надеть на грудную клетку больного, прибинтовать или плотно завязать пришитыми к жилетке тесемками. Если клеенка или вата не полностью прикрывает мокрую тряпку или компресс плохо прибинтован, то между кожей и компрессом проникает наружный воздух, и вода, усиленно испаряясь, вызывает не согревание, а охлаждение.

Согревающий компресс держат 12 часов. Чтобы сохранить кожу от раздражения, надо после снятия компресса насухо вытереть ее полотенцем.

**КОМПРЕСС СПИРТОВОЙ (ВОДОЧНЫЙ)** ставят так же, как обычный (с водой), только материю смачивают не водой, а разбавленным спиртом или водкой, меняют его через каждые 4—6 часов.

**КРОВОПУСКАНИЕ** см. *Венепункция, Венесекция.*

**ЛЕД.** Применяется в пузырях для льда из резины или прорезиненной материи. Посредине мешка имеется сравнительно большое отверстие, закрывающееся плотно заворачивающейся металлической пробкой. Куски льда разбивают в тряпке на мелкие кусочки и наполняют ими пузырь до половины. Для удаления воздуха из пузыря его выжимают, скручивая свободную часть пузыря, и заворачивают пробку. Чтобы не вызвать чрезмерного охлаждения кожи и даже

ее обморожения, пузырь со льдом всегда кладут на сложенное полотенце. Вначале, вследствие осадения на холодной поверхности пузыря паров окружающего воздуха, пузырь становится мокрым, поэтому его надо вытирать. С некоторыми перерывами лед может лежать часами. Чтобы пузырь не падал с головы, его иногда привязывают к спинке кровати. Если пузырь вызывает резкую боль в результате производимого им давления, например, при воспалении брюшины, переломах и пр., его подвешивают над больным местом. По мере таяния льда воду сливают и подкладывают новые кусочки льда. Вместо льда пузырь можно наполнять снегом.

**МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОМЫВАНИЕ** см. *Промывание мочевого пузыря.*

**МУШКА.** Пластырь, в состав которого входят шпанские мушки, растертые в порошок. Они содержат чрезвычайно ядовитое и раздражающее вещество — кантаридин. Мушка намазывается на плотную ткань, края которой обведены липким пластырем. Прежде чем ставить мушку, нужно выбрить кожу, если на ней имеются волосы, вымыть ее и протереть спиртом. Мушку слегка подогревают и плотно прикладывают к намеченному месту, прижимая края, затем ее прикрепляют полосками липкого пластыря или небольшой повязкой. Мушку держат 12 часов, после чего под эпидермисом образуется воспалительная жидкость (экссудат). Мушку слезет снимать чрезвычайно осторожно, чтобы вместе с ней не сорвать эпидермис: ее снимают правой рукой, левой постепенно отслаивая кожу, оставшиеся на коже черные частички кантаридина аккуратно снимают ваткой или марлевым тампоном, смазанным вазелином, прикладывая его к каждой частичке кантаридина. Когда кожа совершенно очищена от мушки, пузырь снизу надрезают стерильными ножницами или скальпелем и выпускают из пузыря жидкость. Края эпидермиса срезать не следует, так как под ним будет образовываться новый эпидермис. Затем накладывают стерильную повязку с вазелином, цинковой или ксероформной мазью. Мушку нельзя ставить при заболеваниях почек.

**МЫТЬЕ РУК<sup>1</sup>.** 1. Способ Спасокукоцкого-Кочергина: руки моют в течение 5 минут в 0,25% теплом растворе нашатырного спирта, сменяя раствор не менее двух раз. Для мытья применяют стерильные салфетки. Руки вытирают насухо стерильной салфеткой и в течение 5 минут обрабатывают спиртом. Концы пальцев смазывают йодной настойкой. 2. Способ Альфельда: моют руки щеткой в горячей воде (до 45°) с мылсАi в течение 5 минут, производят механическую очи-стку ногтей и околоногтевых валиков, вновь обмывают водой, вытирают насухо стерильным полотенцем и обмывают в течение 5 минут спиртом.

Уход за кожей рук. Наиболее загрязнена патогенными микроорганизмами кожа рук. Бактерии находятся в многочисленных складках и углублениях, в глубоких слоях эпителия, сальных железах и волосных луковицах. Наиболее инфицированы подиогтевые пространства, ногтевые валики, ладонная сторона пальцев, ладонь. Только руки без трещин, ссадин и царапин могут

<sup>1</sup> Проф. А. Н. Великорецкий.

быть удовлетворительно обеззаражены. Предварительный уход за руками состоит в горячих ваннах и смазывании рук на ночь смесью равных количеств вазелина и ланолина (Vasolini, Lanolini aa20,0) с тщательным втиранием этой мази. Нередко применяется на ночь и после мытья смазывание глицерином в чистом виде или в смеси: Liqueoris Ammonii caustici, Glycerini, Aq. Amygdalarum aa20,0.

**ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ<sup>1</sup> (СТЕРИЛИЗАЦИЯ).** Достигается лучше всего физическими методами (высокой температурой): 1) прокаливанием, обжиганием, 2) кипячением, 3) текучим паром, 4) паром под давлением.

**Прокаливание.** Применяется для стерилизации лишь немногих предметов (лоточков, тазов и пр.). В таз наливают немного денатурированного спирта, тщательно ополаскивают им весь сосуд и зажигают.

**Кипячение.** Обычно пользуются кипятильником или стерилизатором. Инструменты, стеклянные предметы, резиновые трубки следует стерилизовать. В стерилизатор наливают воду, лучше горячую, и кладут нужные инструменты. Закрыв стерилизатор крышкой, ставят на огонь или, если он электрический, включают в сеть. Когда вода закипит, стерилизатор продолжают держать на огне еще 30 минут. Стеклянные предметы заливают холодной или слегка теплой водой. Дренажи кипятят не более 15—20 минут. В тех случаях, когда инструменты инфицированы спороносными бактериями (столбняк и газовая флегмона), их кипятят тотчас по употреблении в течение 40 минут и повторяют кипячение с перерывами 2—3 раза.

Стеклянные предметы (мензурки, шприцы, пробирки) кипятят отдельно от металлических инструментов, завернув в марлю, причем шприцы разбирают на отдельные части и каждую часть завертывают отдельно.

Все режущие инструменты (скальпели, ножницы) стерилизуют заливанием их спиртом на 30 минут. Спирт должен покрывать инструмент целиком.

Наиболее надежная и быстрая стерилизация производится паром под давлением в специальном аппарате — автоклаве. В нем можно стерилизовать инструменты, белье, перевязочный материал, одежду и предметы обихода. От длительной стерилизации кипячением портится резина.

На крышке автоклава имеется манометр, который отмечает давление пара внутри аппарата в атмосферах. О температуре внутри аппарата судят по давлению: давление на 1 атм. выше обычного будет всегда соответствовать температуре 120°, в 2 атм. — 134° и т. д. На циферблате манометра имеется красная черта, указывающая, что превышение данного давления опасно. Предохранительный клапан автоклава установлен так, что он сам начинает выпускать пар, если манометр будет показывать давление выше 2 атм.; в этот момент пар приподнимает пластинку с гирькой.

Чтобы получить надежную стерилизацию, вполне достаточно, чтобы стрелка манометра показывала давление между 1 и 2 атм.

\* Проф. А. Н. Велюкорецкий.

При соответствующей этому давлению температуре в 120—134° стерилизация длится обычно 30—40 минут.

**Техника.** Налить в аппарат воды, так как подогревание без воды тотчас испортит аппарат. Наполнив внутреннюю камеру автоклава стерилизуемыми предметами, закрывают и привинчивают крышку; подогревают аппарат при открытом кране. Когда из крана начинает выходить пар равномерной струей (это указывает на то, что воздух из аппарата вытеснен), кран закрывают и следят за манометром. Когда давление поднимется до 1 атм., следует открыть еще раз кран и выпустить пар, чтобы вместе с ним вышли остатки воздуха; затем кран закрывают и ждут, когда стрелка манометра остановится на 1; этот момент считают началом стерилизации. Во все время стерилизации стрелка должна находиться между цифрами 1 и 2. По окончании стерилизации, когда аппарат немного остынет, выпускают полностью пар и только затем отвинчивают и открывают крышку, вынимают стерилизованные вещи. Если ждать полного остывания, то все стерилизованные вещи могут оказаться совершенно мокрыми.

**Контроль стерилизации. Красочные пробы.** 1. На бумажках ализариновой краской Шотнера написано: «Стерилизовано». Под влиянием пара при температуре 100° написанное бледно-желтой краской слово приобретает ярковинную окраску. 2. Бумажки пропитывают крахмалом и затем погружают в люголевский раствор; при стерилизации они теряют свою темносинюю окраску. Обе пробы ненадежны. 3. Применяют сплавы металлов или веществ, плавящихся при определенной температуре (резорцин плавится при 110°). Резорцин кладут в особые стеклянные трубочки с двойными стенками, в которых можно получить расплавление лишь через 15 минут. Этим способом получают данные для суждения о достаточной длительности стерилизации. 4. Более верные и надежные результаты дают бактериологические методы. В середину стерилизуемого материала кладется материал, инфицированный какими-либо спороносными бактериями, и по окончании стерилизации он подвергается исследованию (посев). Ответ может быть получен лишь на 2—3-й день.

**ОБЕРТЫВАНИЕ.** Влажные обертывания бывают согревающие и охлаждающие. Для согревающего обертывания на постели или на кушетке раскладывают одно или два шерстяных одеяла, поверх кладут смоченную в горячей воде (45—50°) и выжатую простыню. Иногда сначала на одеяло кладут большую клеенку, чтобы не мочить одеяла. Заранее раздетый больной быстро ложится по середине простыни и поднимает руки. Одной стороной простыни обертывают тело больного, затем больной опускает руки вдоль туловища, и другой стороной простыни покрывают больного с руками. Простыня закладывается складкой между ногами. Затем больного быстро укутывают одеялами, нижний конец которых подвешивается под ноги. Иногда дают больному выпить стакан горячего чая. Согревающее укутывание продолжается 20—60 минут, а иногда и дольше. При падении пульса, наступлении общей слабости, головокружении процедуру следует прекратить и больного развернуть. При холодных обертываниях простыню смачивают в холодной воде (20—10°),

обертывают тело так же, как при согревающих обертываниях. Процедура продолжается всего несколько минут (3—10). Часто поверсты больного растирают.

**ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ.** Определение групп крови. По гемолитическим свойствам кровяной сыворотки всех людей можно разделить на четыре основные группы<sup>1</sup>: первая группа обозначается 0(1), вторая — А(II), третья—В(III), четвертая — АВ(IV).

**Техника.** На чистом предметном стекле или, еще лучше, на краях белой фарфоровой тарелки специальным цветным карандашом на равном расстоянии пишут обозначения трех первых групп: 0(1), А(II) и В(III). На тарелку или предметное стекло у места 0(1), А(II) и В(III) последовательно разными пипетками наносятся по одной крупной капле стандартной сыворотки группы 0(1), А(II) и В(III). Каждая пипетка, после того как из нее выпущена капля сыворотки, немедленно опускается в тот флакон с сывороткой, из которого она была взята.

Три капли крови, каждая величиной с булавочную головку, последовательно переносятся стеклянной палочкой на тарелку или предметное стекло рядом с ранее нанесенными каплями сыворотки группы 0(1), А(II) и В(III).

Заметив на часах время, стеклянной палочкой перемешивают кровь с сывороткой группы 0(1) до тех пор, пока смесь не примет равномерно розового цвета. Так же поступают с сывороткой остальных групп. Для каждой капли берут специальную стеклянную палочку.

Определение группы крови производится в течение 5 минут (следить по часам).

По истечении 5 минут к каждой капле смеси добавляется по одной капле физиологического раствора, после чего производится окончательная оценка результатов.

Чтобы судить о результате исследования, нужно выждать 5 минут. Сыворотка чужой группы вызывает агглютинацию (склеивание, собирание в кучки) эритроцитов, которые выпадают в виде хлопьев. Если со всеми тремя каплями агглютинации не получилось, то кровь больного принадлежит к первой группе — 0(1); если агглютинация имеет место с сывороткой 0(1) и В(III), то испытуемая кровь принадлежит ко второй группе — А(II); если с 0(1) и А(II), то к третьей группе — В(III); если же агглютинация произошла во всех трех каплях, то кровь принадлежит к четвертой группе — АВ(IV).

Лучше переливать кровь одноименной группы; при невозможности следует придерживаться обязательно следующих правил:

1. Кровь I группы можно переливать лицам любой, группы.
2. Кровь II группы можно переливать лицам II и IV группы.
3. Кровь III группы можно переливать лицам III и IV группы.
4. Кровь IV группы — только лицам IV группы.

<sup>1</sup> Прсф. А. Н. Великорескпй.

<sup>2</sup> Кроме основных, имеются так называемые подгруппы, не имеющие большого практического значения.

Кроме определения группы крови, перед самым переливанием (независимо от того, что раньше уже было произведено это определение) следует произвести реакцию на совместимость крови. Для этого берут 3 капли сыворотки крови больного, смешивают с каплей донорской крови и в течение 5 минут следят за получаемой реакцией. Если получится реакция агглютинации, то кровь донора надо считать несовместимой с кровью больного.

Для переливания пользуются обычно консервированной кровью. Для консервации применяются либо специальные жидкости, либо 4—6% раствор лимоннокислого натрия (по 10 мл на 100 мл крови). Хранится кровь на леднике при температуре 2—4°; можно употреблять кровь, хранящуюся даже 15—20 дней, если она не подверглась изменениям. Плазма над осевшими эритроцитами должна быть прозрачной, янтарного цвета, без сгустков, хлопьев и пленок. Перед переливанием кровь согревают до комнатной температуры, ставя ее в сосуд с теплой водой и подливая воду все время с таким расчетом, чтобы она имела температуру не выше 38—39°. Через 15 минут кровь может быть перелита. Пробку, закрывающую банку с кровью, заменяют другой с двумя введенными в нее стеклянными трубками, причем одна длинная (почти до дна сосуда), другая короткая. На короткую трубку надевают резиновую трубку с канюлей. Трубку закрывают зажимом. На длинную трубку надевают резиновую с резиновым же баллоном для наг: зтания воздуха (в целях усиления поступления крови в вену). Сжимать баллон надо очень осторожно и медленно. Пробку крепко привязывают к горлышку банки. Пробка и все трубки должны быть стерильными. Вынутую из воды банку обтирают и перевертывают, зажим снимают для удаления воздуха и наполнения системы кровью, после чего резиновую трубку вновь зажимают и банку, повернутую вверх дном, подносят к делаящему переливание; ему же передают резиновую трубку и заранее приготовленную специальную иглу для переливания крови. Обычно переливание производят в локтевую вену. Операционное поле готовят обычным образом (см. *Венепункция, Венесекция, Впрыскивания внутривенные*). Как только из введенной в вену больного иглы показалась струйка крови, снимают зажим и канюлю надевают на иглу. Этим способом избегают попадания воздуха в систему. Вместо специальных банок часто применяют особые ампулы, в которых кровь заготавливается и из которых она переливается. Резинку на верхнем конце ампулы срезают, и кровь по резиновой трубке нижнего конца ампулы поступает в трубку, заканчивающуюся иглой. В остальном поступают, как описано выше.

Осложнения, ошибки, опасности зависят от технических погрешностей, от нарушения правил переливания крови и в первую очередь от неправильного определения группы крови. Вот почему перед самым переливанием надо вторично проверить и группу крови больного, и группу консервированной крови и провести пробу на совместимость. Появление агглютинации там, где ее на самом деле нет (ложная агглютинация), наблюдается в случаях, когда исследование производится при температуре ниже 10°, при способности сыворотки вызывать агглютинацию со всеми эритроцитами, при сгущении сыворотки и высыхании капли, несвежей

взвеси эритроцитов и недостаточно чистой посуде. Для выяснения, нет ли псевдоагглютинации, разбавляют каплю сыворотки физиологическим раствором и вновь смешивают ее, слегка подогревая. Появлению агглютинации может препятствовать повышение температуры более 30°, слабый титр сыворотки, чрезмерное количество эритроцитов и недостаточная продолжительность наблюдения.

При нарушении правил взятия и консервирования или переливания крови возможно попадание в русло кровообращения больного сгустков крови или воздуха, что может дать тяжелую картину эмболии сосудов мозга или сердечных. Реакция на переливание наступает через 20—40 минут. Она состоит в появлении озноба, головной боли, боли в крестце, учащении пульса. Затем озноб сменяется чувством жара, повышением температуры до 39—40°. Достигнув максимума через 4—6 часов, температура снижается.

Необходимо обложить больного грелками, следить за пульсом, ввести 1,0 кофеина под кожу, срочно исследовать мочу, чтобы вовремя выявить возможное поражение почек.

Осложнения возникают иногда через 2—3 минуты после введения даже небольшого количества крови.

Для предупреждения тяжелого осложнения, которое бывает при несовместимости крови, переливание начинают с биологической пробы, т. е. введения небольшого (10—20 мл) количества крови, и выжидают 5 минут, не вынимая иглы из вены. Если у больного пульс не падает, нет общего беспокойства, цианоза, болей в животе и пояснице, то продолжают переливание дальше. При появлении указанных выше симптомов вливание прекращают и в случае необходимости — внутривенно глюкоза 40% 10—20 мл, физиологический раствор 50—100 мл.

Переливание крови капельное производится по правилам для капельного внутривенного вливания (см.) больших количеств жидкости и при соблюдении всех тех правил, о которых говорилось выше.

**ПЕРЧАТКИ** \*. Перчатки тотчас после использования моют и тщательно высушивают. Кровь или гной должны быть смыты с перчаток, пока они еще не сняты с рук. Перчатки моют кипятком с мылом, протирают насухо с обеих сторон и сушат. Инфицированные перчатки после предварительного обмывания под краном сразу после применения опускают в какой-либо дезинфицирующий раствор (сулема, лизол, карболовая кислота), затем моют с мылом, кладут в такой же дезинфицирующий раствор на 20—30 минут, прополаскивают и кипятят 15 минут. Для проверки целостности перчаток их надувают и смотрят, не проходит ли воздух; можно погрузить надутые перчатки в таз с водой: при наличии мельчайшего прокола его можно обнаружить по выходу пузырьков воздуха.

Место, которое нужно зачинить, а также заплату тщательно обмывают бензином и смазывают специальным резиновым клеем; слегка подсушив клей, накладывают заплату на место разрыва и плотно прижимают чем-либо до полного высыхания клея. Заплату надо класть с внутренней стороны.

<sup>1</sup> Проф. А. Н. Великорецкий.

**Стерилизация.** Перчатки можно простерилизовать в автоклаве. Перед стерилизацией их надо подобрать по номерам и попарно (правая и левая) тщательно пересыпать тальком и завернуть каждую пару в отдельную салфеточку (матерчатую или марлевую). В пальцы перчатки при стерилизации вставляют марлевые салфетки, чтобы надежнее предохранить резину внутри пальцев от слипания. Перчатки стерилизуют в автоклаве при давлении в 1,5 атм. в течение 15 минут, но они менее портятся при стерилизации текучим паром под небольшим давлением при 105° в течение 40 минут. После этого в течение 15 минут перчатки высушивают в автоклаве. Можно стерилизовать перчатки и кипячением в растворе соды в течение 15 минут. Чтобы перчатки легче надевались, смачивают руки стерильным глицерином, спиртом или после обтирания их стерильным полотенцем припудривают тальком.

**ПИТАНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ.** Кормят больных через тонкий зонд длиной приблизительно 30 см, который вводится через нос. Зонд кипятят, смазывают глицерином и осторожно вводят вдоль стенки носа кзади. Если больной закашляется или через зонд начнет входить и выходить воздух и появится одышка, значит зонд попал в дыхательное горло, и нужно его немедленно извлечь и ввести снова. На другой конец надевается воронка, через которую вливают жидкую пищу. При заражении пищевода производят кормление через фистулу (отверстие в желудке). Зонд вводят, через фистулу в желудок, а на другой конец надевается воронка. Надо следить, чтобы рана не загрязнялась и чтобы желудочный сок не разъедал края раны.

**ПИЯВКИ.** Чаще всего пиявки ставят за ушами к сосцевидным отросткам, к шее под затылком или к копчику, а иногда и к другим частям тела: области печени (застой печени), сердца (инфаркт миокарда), закупоренных и воспаленных вен (тромбофлебиты). Пиявки должны быть голодные (тонкие, быстро двигающиеся), иначе они негодны для употребления. Кожу больного надо вымыть с мылом, но не туалетным, так как вследствие запаха отдушки мыла пиявки могут не присосаться. Кроме того, кожу сильно растирают, чтобы вызвать гиперемию, а иногда смачивают сахарной водой или кровью: тогда пиявки охотнее присасываются. Во время процедуры больной должен лежать. Пиявку захватывают пальцами около головного конца, который прикладывают к коже и ждут, пока пиявка присосется. Иногда пиявку кладут в пробирку головным концом к выходному концу пробирки, плотно приставляют последнюю к коже и ждут, пока пиявка присосется. За один прием ставят 4—6—8, а иногда и больше пиявок. Если пиявка быстро отпадает, значит она не годится, и на ее место надо поставить другую. Пиявка насасывает кровь в среднем %—1 часа. Если пиявка долгое время не отпадает, ее нельзя отрывать, а нужно посыпать на нее немного соли или полить соленой водой, тогда она сама быстро отпадет. Пиявки нельзя ставить на места с поверхностно расположенными кровеносными сосудами, так как они могут прогрызть стенку сосуда и вызвать обильное кровотечение. После того как пиявка отпадет, кровь продолжает довольно долго сочиться из ранки благодаря особому веществу — г и р у д и н у, выделяемому пияв-

ками, которое понижает свертываемость крови. После отпадения пиявки некоторое время дают крови свободно течь, а затем накладывают стерильную повязку. Если ранки продолжают кровоточить, то их повторно смазывают иодом или прижигают полутора-хлористым железом и накладывают тугую давящую повязку. Иногда кровотечение становится угрожающим и приходится ранки зашивать или накладывать на них скобки.

**ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТИ ВЫПУСКАНИЕ** см. *Прокол плевры*.

**ПОВЯЗКИ** \*. Винтовые. Ширина бинта — от 5 до 10—20 см, смотря по тому, на какую часть тела она накладывается, длина — около 5—7 м. Обычно бинт в 5 см употребляется для бинтования пальцев, в 7—9 см — для бинтования головы, предплечья, плеча, голени, в 9—18 см — для бинтования бедра и туловища. **К р у г о в а я п о в я з к а**. Конец бинта накладывают на бинтуемую часть тела, удерживают левой рукой, правой же разматывают бинт и обороты его ведут так, что один ложится на другой, прикрывая его целиком. **С п и р а л ь н а я п о в я з к а**. Начинают, как предыдущую, с 2—3 круговых ходов, а затем ходы бинта ведут в косом направлении (спирально), лишь частично, на  $\frac{2}{3}$ , прикрывая предыдущий ход; когда же толщина конечности неодинакова, прибегают к перегибам. **К р е с т о о б р а з н а я** (восьмио б - р а з н а я) повязка называется колосовидной повязкой. Если в восьмиобразной повязке ходы бинта в месте перекреста прикрывают предыдущие не вполне, а, перекрещиваясь по одной линии, ложатся ниже или выше предыдущих, то место перекреста напоминает вид колоса; в этом случае повязка будет колосовидной.

**Гипсовая повязка. П р о б а г и п с а**. При нагревании гипса (проба нагреванием) из него не должны выделяться пары воды, что легко определить, если над гипсом подержать зеркальце (оно запотеет). Проба на затвердение: небольшое количество гипса смешивают с таким же количеством воды, чтобы получилась гипсовая каша, напоминающая жидкую сметану. Эта каша должна застывать в течение а—6 минут.

**У л у ч ш е н и е к а ч е с т в а г и п с а**. При наличии комков и крупинок гипс просеивают через сито или протирают через натянутую над ведром редкую марлю. Можно улучшить качество отсыревшего гипса, прокалив его, но при температуре не выше 140°, поставив на несколько минут в протопленную печь.

Сохраняют гипс в металлических или стеклянных банках с притертыми пробками.

**П р и г о т о в л е н и е г и п с о в ы х б и н т о в**. Белую марлю для бинтов лучше резать, а не рвать. Длина бинта не более 2,5—3 м. Гипс втирают в бинт, нагипсованный конец осторожно складывают вдвое, вчетверо и т. д., скатывая таким образом про-гипсованную часть.

**Н а л о ж е н и е п о в я з к и**. Гипсовый бинт кладут в таз с водой. Толщина слоя воды в тазу должна быть вдвое больше тол-

Проф. А. Н. Велииорекский.

щины бинта. При промокании (прекращается выделение пузырьков воздуха) бинт вынимают и отжимают не туго, захватив концы бинта, чтобы из них не вытекла каша.

Каждым ходом бинта покрывают  $\frac{2}{3}$  предыдущего. На месте перегибов бинт подрезают с противоположной стороны или расправляют. К концу наложения первого бинта должен быть готов второй и т. д., пока повязка не будет иметь 2—3 слоя на верхней конечности, 3—4 — на голени и бедре, 5—6 — на туловище. Необходимо работать быстро, приготовив все необходимое заранее и правильно и удобно расположив материалы для повязки. После каждого слоя тщательно протирают повязку, пригоняя ее к неровностям (моделируя). Закрепляют концы повязки, подрезав гипс, иссекая круговую полосу шириной в 1—2 см.

Для повязки готовят следующие предметы: прогипсованных 13-сантиметровых бинтов не менее 6 штук — для повязки на туловище (корсет), 5 штук 13-сантиметровых и 4 штуки 6,5-сантиметровых — для повязки на бедро и голень, 4—6 штук 6,5-сантиметровых — для повязки на плечо и 2 штуки 6,5-сантиметровых — для повязки на предплечье; вата пластами или бинтами; простые бинты; таз, кувшин с водой; ножницы и нож для подрезания повязки. Для снятия — повязку разрезают, смачивая ее горячей водой, раствором поваренной соли или, еще лучше, слабым раствором соляной кислоты.

**Виды гипсовых повязок. О к о п ч а т а я п о в я з к а**. В повязке соответственно больному месту вырезают окно; кругом окна закладывают вату, лучше всего промоченную раствором шеллака в спирту или в коллодии.

**Ш и н н ы е г и п с о в ы е п о в я з к и** (лонгетки). Гипсовый бинт, соответствующий по ширине узкому месту выкройки, смачивают, как обычно, и укладывают продольными полосами. Количество слоев бинта: 10—15 — для нижней конечности, 5—8 — для верхней. Полосу тщательно разглаживают, плотно прижимая слои шины одни к другим. Лонгетка должна быть приготовлена быстро, пока гипс не начал застывать. Шину кладут на конечность, прибинтовывают и ждут, пока она не подсохнет. Повязка лонгеткой может быть приготовлена и иным способом: марлю выкраивают по выкройке, укладывают в 10—15 слоев и прогипсовывают. Готовые шины-лонгетки необходимо смочить и расправить.

**П о в я з к и л о н г е т к о й**. Необходимы лонгетки в 8—10 слоев и ватные подушечки для защиты костных точек (крестец, гребешки подвздошных костей и т. д.). Перед наложением необходимо уменьшить отечность конечности, придав ей возвышенное положение. Повязки лонгетками применяются при большинстве переломов предплечья, плеча, голени, кисти и стопы.

**Клеоловая повязка**. Прикрыв рану свернутой в несколько слоев марлей, окружность повязки смазывают помазком, смоченным клеолом, и ждут, пока она несколько подсохнет. После этого прикрывают всю область, смазанную клеолом, растянутой марлевой салфеткой и плотно ее прижимают. Края повязки, не прилипшие к коже, подрезают ножницами. Рецепт клеола: канифоль 50,0, эфир 100,0, скипидар 1,0.

**Коллодийная повязка.** Свернутая в несколько слоев марля закрывает область раны; на нее накладывают развернутую марлевую салфетку, заходящую со всех сторон на несколько сантиметров за края первой. Эти свободные края верхней салфетки, прилегающие прямо к коже, смачивают коллодием. При застывании коллодия края плотно прилипают к коже и хорошо удерживают всю повязку.

**Косыночная повязка.** Перевязь употребляют при ряде гнойных заболеваний и повреждений кисти, предплечья и плеча, при переломах ключицы и т. п. Середину косынки кладут под согнутое под прямым углом предплечье; основание ее располагается по средней линии тела, а верхушка направлена к локтю между туловищем и рукой; концы завязываются на шею. При оказании экстренной помощи косынку можно сделать из любого платка, сложив его с угла на угол. Косынка может быть использована для наложения повязок на любую часть тела.

**Пластырная повязка.** Полоски липкого пластыря накладывают поверх перевязочного материала, переходя на кожу с той и с другой стороны. Применяют липкопластырную повязку: окись цинка — 100,0, желатина — 200,0, вода — 300,0, глицерин — 400,0. Клеевую массу готовят следующим образом: желатиновые пластинки кладут на несколько минут в холодную воду, пока они не впитают до 200,0 воды и не набухнут (станут мягкими). Их отжимают, ставят в сосуде в кипящую воду и перемешивают, пока они не растворятся. Одновременно с этим смешивают окись цинка с 300,0 воды; получается густая каша, в которую, помешивая, добавляют глицерин. Этот раствор прибавляют к жидкой желатине и выливают в плоскую чашку, где масса застывает. При употреблении берут кусок массы, распускают в сосуде, поставленном в горячую воду, и намазывают кистью полоски материи.

**Шинная\* повязка.** Цель повязки — создать покой для поврежденной части, уменьшить болезненность в поврежденной конечности во время переноски и перевозки больного и предупредить повреждение мягких тканей костными отломками при переломах. Поднимать конечность и накладывать повязку необходимо очень осторожно при некотором вытяжении конечности. Основное правило: не только иммобилизация области повреждения, но и установление в неподвижном состоянии по крайней мере двух ближайших суставов (один выше, другой ниже места повреждения), а при повреждениях бедра — трех суставов. Пользуются готовыми металлическими шинами из различных металлов — жести, цинка, железа и алюминия. Из металлических шин чаще применяют проволочные в виде двух толстых проволок с перекладинами (крамеровские). Шину приспособляют к любой части тела путем раздвигания проволочных перекладин и сгибания продольных проволок. Применяют шины из деревянных дощечек, лубка, лучины, картона. При отсутствии готовых шин их импровизируют, пользуясь предметами окружающей обстановки (прутья, пучки соломы и т. д.). Для транспортировки пострадавших с повреждением конечностей имеются транспортные шины; для бедра и верхних двух третей голени удобна шина Дитерихса.

**ПРОБНЫЕ ЗАВТРАКИ** см. *Зондирование желудка.*

**ПРОКОЛ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ** при наличии в ней жидкости производят троакаром. Положение больного сидячее, прислонившись к стенке стула, а тяжело больных — лежащее на левом боку. Место прокола — по средней линии немного ниже середины расстояния между пупком и лобком или несколько кнаружи от середины расстояния между пупком и левой передне-верхней остью подвздошной кости.

Лучше делать прокол по средней линии, чтобы не поранить подкожные вены. Перед проколом надо обязательно, если только возможно, определить, насколько выстоит над лобком мочевого пузыря, а у женщин и матка.

Если из-за величины асцита этого сделать невозможно, то лучше прокол произвести несколько выше. Перед процедурой больной должен помочиться. Поле прокола, а также руки врача готовят, как для операции. Место прокола анестезируют несколькими миллилитрами 0,25% раствора новокаина, приставляют троакар с мандреном и путем нажима прокалывают кожу. Затем удаляют мандрен; трубка же остается в брюшной полости, и по ней жидкость вытекает наружу. Жидкость следует выпускать медленно, живот стягивать полотенцем. После удаления троакара на отверстие накладывают шов и коллодийную повязку. Количество выпущенной жидкости должно быть точно зафиксировано в истории болезни.

**ПРОКОЛ ПЛЕВРЫ.** Прокол производят с целью определить, имеется ли в полости плевры жидкость и каков ее состав. Прокол делают в шестом-восьмом межреберье по задней предмышечной или лопаточной линии. Кожу больного протирают спиртом и эфиром, а затем смазывают иодом. Шприц, иглы и руки стерилизуют обычным способом (см. *Впрыскивания подкожные и Вливания внутривенные*). Смазывают иодом крайнюю фалангу указательного пальца, которым фиксируют углубление между ребрами, и вдоль пальца вводят между ребрами (у верхнего края ребра) иглу с надетым на нее 10- или 20-граммовым шприцем, которым осторожно вытягивают из плевры жидкость. Если нужно удалить из полости плевры большое количество жидкости, то ее откачивают с помощью аппарата Потена или, еще лучше, Леонова.

Аппарат Потена состоит из градуированной стеклянной бутылки, плотно закрываемой резиновой пробкой, через которую пропущены две изогнутые металлические трубки с кранами. Одна металлическая трубка соединена резиновой трубкой с насосом, а другая — с иглой. Нужно обязательно трубку надеть на боковой конец насоса: в противном случае воздух из бутылки не будет откачиваться, а, наоборот, будет нагнетаться, что может повести к введению воздуха в полость плевры.

Сначала открывают кран трубки, идущей к насосу, и выкачивают воздух из бутылки при закрытом кране второй трубки. Стерильную иглу вкалывают в полость плевры таким же образом, как и при пробном проколе, затем закрывают кран трубки, идущей к насосу, и открывают кран трубки, идущей к игле. Благодаря отрицательному давлению в бутылки жидкость из полости плевры стечет.



кает в склянку. Когда жидкость перестанет поступать в бутылку, из нее вновь откачивают воздух. За один раз выкачивают 500,0—1 000,0 жидкости, а иногда и больше.

Аппарат Леонова представляет собой удлинённый стеклянный цилиндр с суженными концами с обеих сторон, прикрепленный к штативу. На верхний конец надевают трубку, которая другим концом соединяется с иглой; на нижний — надевают трубку, которая опущена в какой-либо сосуд. Предварительно цилиндр наполняют водой и на нижнюю трубку надевают зажим Мора. После того как игла введена в полость плевры, открывают зажим, и вода будет вытекать из сосуда, а в него будет поступать жидкость из полости плевры. По количеству воды, вытекшей из цилиндра, судят о количестве жидкости, выпущенной из полости плевры.

**ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА.** Сначала вводят в желудок толстый желудочный зонд и извлекают все содержимое желудка (см. *Зондирование желудка*). Затем на конец зонда надевают соединительную стеклянную трубку, па другом конце которой закрепляют резиновую трубку с воронкой емкостью в 500—1 000 мл. Воронку опускают ниже уровня желудка и наполняют теплой (30—36°) водой. После этого воронку постепенно поднимают несколько выше головы больного, и вода в силу тяжести наполняет желудок. Воронку быстро опускают вниз, когда в ней останется немного воды, и вода легко проходит из желудка обратно в воронку. Нужно внимательно следить, чтобы не вся вода из воронки прошла в желудок, так как в этом случае трудно будет выкачать обратно промывную воду. Из воронки воду выливают в подставленный таз, снова наполняют воронку водой, поднимают ее, промывают желудок, опускают воронку и выливают воду. Таким образом промывают желудок, пока вода, вытекающая из желудка, не станет совершенно чистой.

Иногда промывание делают водой с примесью каких-либо лекарственных веществ, например, слабым раствором соды (0,5—1%), марганцовокислым калием и др.

**ПРОМЫВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ** производят из обычной кружки Эсмарха, резиновую трубку которой надевают на введенный в мочевой пузырь катетер. Жидкость должна быть подогрета до 38—40°. Кружку помещают на 1—1,5 м выше уровня кровати или гинекологического кресла. За один прием вводят 100—400 мл жидкости; затем резиновую трубку снимают с катетера, выпускают жидкость из мочевого пузыря, снова надевают трубку и так повторяют несколько раз. Можно произвести промывание мочевого пузыря, не вводя в него катетера. На резиновую трубку надевают небольшой наконечник из плотной резины с конусообразным носиком, который вкладывают в начальную часть мочеиспускательного канала и плотно придерживают. Техника промывания та же, что и с катетером. Чтобы расслабить сфинктер мочевого пузыря, больному предлагают сделать такое напряжение, как будто он мочится. После того как в мочевой пузырь введено определенное количество жидкости, наконечник вынимают, больной мочится, затем наконечник снова вкладывают; таким образом мочевой пузырь промывают несколько раз.

Приборы и жидкость для промывания должны быть стерильными. Для промывания применяют физиологический раствор, 2—3% раствор борной кислоты, 1 : 2 000—1 : 5 000 растворы азотнокислого серебра, 1 : 10 000—1 : 5 000 растворы марганцовокислого калия и др.

**СОГРЕВАЮЩИЙ КОМПРЕСС** см. *Компресс согревающий.*

**СПИРТОВОЙ КОМПРЕСС** см. *Компресс спиртовой.*

**СПРИНЦЕВАНИЕ ВЛАГАЛИЩА** производят из кружки Эсмарха. На резиновую трубку длиной 1,5 м надевается слегка изогнутый стеклянный наконечник. Больная лежит либо на гинекологическом кресле, либо на постели с несколько приподнятым тазом. Ноги согнуты в коленных суставах, приведены к животу и раздвинуты. Количество воды —■ 1—2 л, а иногда и больше. Делают прохладные спринцевания (20—30°), теплые (35—40°) и горячие (до 45°). Под больную ставят подкладное судно. Пальцами левой руки разводят половые губы, обнажают вход во влагалище и вводят в него почти до отказа наконечник, в который уже заранее пущена по трубке жидкость путем открытия крана или снятия зажима. По окончании спринцевания осушают стерильной ватой наружные половые органы. После спринцевания больной предоставляет на 45—60 минут покой; лучше всего делать спринцевание перед сном. Наконечник должен быть стерилизован, кружка и трубка продезинфицированы.

Для спринцевания употребляют растворы борной кислоты, марганцовокислого калия, хлористого цинка, молочной кислоты, соды и др.

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ** см. *Обеззараживание.*

**ФРИКЦИИ** см. *Втирания.*

## ГЛАВА XV

## ПРОСТЕЙШИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

**ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ.** Техника взятия крови.

Кровь из пальца можно получить при помощи любого колющего инструмента: иглой от шприца, писчим пером, оспопрививательным перышком и т. д. Наиболее удобным инструментом является специальная игла для взятия крови. Она состоит из ланцета с пружиной, который находится в металлическом футляре. На ланцет навинчивается муфта так, чтобы острие ланцета выстояло на большую или меньшую величину (обычно 2—3 мм). Иглу обеззараживают спиртом, тщательно протирая ее. Место кожи, где берется кровь, протирают спиртом, а затем эфиром. Кровь берут из ногтевой фаланги пальца больного. Если руки больного загрязнены, то предварительно их нужно вымыть мылом со щеткой. Иглу втягивают в футляр (колпачок), который плотно приставляют перпендикулярно к пальцу; затем нажимают замок, пружина спускается, игла пробивает кожу на глубину, соответствующую выступающему из колпачка кончику иглы. Поэтому предварительно устанавливают длину кончика ланцета, выстоящего из муфты. Первую выступившую каплю стирают кусочком стерильной марли. Кровь берут из второй и следующих капель. После взятия крови нужно приложить к месту укола кусочек стерильной марли или ваты и предложить больному прижать ее другим пальцем.

**Определение количества гемоглобина** производят при помощи гемометра. Он состоит из металлического футляра, в середину которого вставляется пустая маленькая градуированная пробирка с делениями от 10 до 140. По обе ее стороны находятся две запаянные пробирки, содержащие определенной крепости раствор солянокислого гематина. В новых приборах вместо пробирок помещают сплошные стеклянные палочки соответствующего цвета.

Перед взятием крови в совершенно чистую и сухую пробирку до метки 10 наливают децинормальный раствор соляной кислоты. Кровь берут из пальца, насыщая ее капиллярной пипеткой, приложенной к прибору до метки 20. Кончик пипетки обтирают ваткой, опускают пипетку до дна пробирки и осторожно выдувают кровь в раствор. Затем этот раствор втягивают и выдувают обратно в пробирку несколько раз, чтобы смыть оставшуюся в пипетке кровь. В результате смешивания крови с соляной кислотой гемоглобин переходит в солянокислый гематин, и раствор приобретает коричневый цвет. Через несколько минут в этот раствор прибавляют пипеткой по каплям дистиллированную воду и помешивают стеклянной палочкой до тех пор, пока цвет раствора испытуемой крови срав-

няется с цветом боковых стандартных пробирок. Деление пробирки, которое будет соответствовать уровню раствора, укажет процент содержания гемоглобина в данной крови. Условно считается, что при 100% гемоглобина и 5 000 000 эритроцитов в 1 мм<sup>3</sup> цветной показатель равен 1.

Цветной показатель вычисляется по следующей формуле: количество гемоглобина исследуемой крови относится к нормальному количеству гемоглобина так, как количество эритроцитов данной крови к нормальному количеству эритроцитов. Например, в исследуемой крови определено 60% гемоглобина и 4 000 000 эритроцитов; цветной показатель будет равен:

$$\frac{60}{100} : \frac{4\,000\,000}{5\,000\,000} \text{ или } \frac{60 \times 5\,000\,000}{100 \times 4\,000\,000}$$

После сокращения получают:

$$|2i|=15=0,75.$$

$$5 \times 4 = 20$$

Упрощенный способ определения цветного показателя: число найденного процента гемоглобина (например, 60) делят на удвоенное число сотен тысяч найденного количества эритроцитов (например, 40;  $40 \times 2 = 80$ ).

$$80 \sim 20 \sim 4 \sim \frac{U}{10}$$

**Определение количества форменных элементов крови.** Кровь набирают в особые смесители, которые представляют собой капиллярные пипетки, заканчивающиеся небольшим стеклянным резервуаром с небольшой свободно лежащей стеклянной бусинкой. Пипетка смесителя для счета красных кровяных телец посередине имеет метку 0,5, в конце — 1, а где оканчивается резервуар — 101. Пипетка смесителя для лейкоцитов имеет такие же деления, но только резервуар ее меньше и в конце его стоит метка И.

Для счета эритроцитов кровь разбавляют 3% раствором поваренной соли. В качестве разбавляющей жидкости для счета лейкоцитов пользуются 5% раствором уксусной кислоты, которая растворяет эритроциты и совершенно не изменяет лейкоцитов.

Для счета эритроцитов берут смеситель с большим резервуаром, насыщают кровь до деления 0,5 или 1 (лучше брать кровь до 0,5), обтирают кончик смесителя ваткой и сразу опускают смеситель в раствор поваренной соли и насыщают его до метки 101. Затем зажимают концы смесителя пальцами одной руки и встряхивают: бусинка в резервуаре равномерно распределяет форменные элементы.

Для счета лейкоцитов берут смеситель с меньшим резервуаром, насыщают кровь до метки 1, обтирают кончик смесителя ваткой и затем набирают до метки 11 раствор уксусной кислоты. По окончании насыщения раствора смеситель хорошенько встряхивают, зажав его концы.

Форменные элементы крови можно считать только под микроскопом в специальной счетной камере. Счетная камера состоит из толстого предметного стекла, на которое наклеен стеклянный кружок. Дно камеры (кружка) представляет тончайшую сетку, состоящую из больших квадратов, из которых каждый в свою очередь разделен на 16 маленьких квадратиков.

Каждый большой квадрат, который под микроскопом занимает почти все поле зрения, отделен от другого тремя тончайшими линиями. Сторона маленького квадратика равна  $\frac{1}{20}$  мм, а площадь, следовательно,  $\frac{1}{400}$  мм<sup>2</sup>. Камера окружена рамкой, которая на 0,1 мм выше сетки. На рамку кладется толстое шлифованное стекло.

Расстояние между сеткой и стеклом равняется 0,1 мм; следовательно, объем одного деления на сетке составит:

$$\frac{1}{10} \times \frac{1}{400} = \frac{1}{4000} \text{ мм}^3.$$

Кружок от рамки отделяется небольшим углублением, куда может вылиться излишек крови, нанесенной на сетку. Существуют различные счетные камеры, устроенные по атому принципу.

Наиболее удобной является камера Предтеченского-Ключарева. На предметном стекле прикреплены две стеклянные пластинки, служащие опорой для покровного стекла. Между ними находится средняя пластинка, плоскость которой на 0,1 мм ниже предыдущих. Эта пластинка разделена на две части поперечным желобком. На каждую половину средней пластинки нанесено по одной сетке, состоящей из 100 больших квадратиков. Каждый большой квадратик разделен на 16 маленьких.

Камера, углубление, рамка и покровное стекло должны быть совершенно чисты и сухи. Прежде чем пустить разбавленную кровь на сетку, нужно снова несколько раз встряхнуть смеситель, как указано выше, чтобы форменные элементы распределились равномерно. Затем выпускают из смесителя 1—2 капли на фильтровальную бумагу и лишь после этого наносят небольшую капельку раствора на сетку. Капелька должна быть только такого объема, чтобы покрыть всю сетку. Когда капля нанесена, ее осторожно, чтобы не образовалось воздушных пузырей, покрывают покровным стеклом, которое плотно прижимают к рамке.

В камере Предтеченского-Ключарева сначала плотно накладывается покровное стекло, а затем капля разведенной крови, висающая на конце смесителя, подносится сбоку к щели между сеткой и покровным стеклом. Жидкость равномерно распределяется между сеткой и покровным стеклом, а излишек ее стекает в поперечный желобок.

Для экономии времени можно на одну сетку пустить кровь для подсчета эритроцитов, а на другую — для подсчета лейкоцитов.

Для более или менее точного подсчета красных кровяных телец достаточно сосчитать их в 5 больших или 50 маленьких квадратиках. Счет производят в определенном порядке. Удобнее всего начинать с верхнего левого маленького квадратика. Считают все эритроциты, расположенные внутри квадратика, а затем на верхней и левой границе. После этого переходят к следующим квадратикам и так сосчитывают количество эритроцитов во всем большом квад-

рате. После подсчета эритроцитов во всем большом квадрате полученное число записывают и препарат подвигают под микроскопом на следующий большой квадрат. Таким образом сосчитывают эритроциты в 5 больших квадратах. Предположим, что в 5 больших или 10 малых квадратах мы насчитали 448 эритроцитов; следовательно,

в одном малом квадрате их будет-тт-г-. Выше было указано, что

$$4 \text{ объем малого квадратика равен } 1 \text{ мм}^3$$

— мм<sup>3</sup>, значит в 1 мм<sup>3</sup> эритроцитов в 4 000 раз больше, т. е.  $4 \times 4000$ .

Кровь была разбавлена

в 200 раз, следовательно, в действительности эритроцитов должно быть в 200 раз больше, чем мы сосчитали:

$$448 \times 1000 \times 10 = 4480000.$$

Это и будет число, указывающее количество красных кровяных телец в 1 мм<sup>3</sup> исследуемой крови. Практически не нужно производить всех указанных арифметических вычислений; достаточно к сосчитанному числу эритроцитов прибавить четыре нуля, чтобы получить количество эритроцитов в 1 мм<sup>3</sup>.

Для подсчета белых кровяных телец препарат готовится таким же образом. Так как лейкоцитов гораздо меньше и на большой квадрат их приходится всего 3—4, то нужно сосчитывать их в большем количестве квадратов, по крайней мере в 25.

Если пользоваться камерой Тома-Цейсса, в которой всего 16 больших квадратов, приходится производить подсчет 2 раза, а при более точном подсчете и больше.

Поэтому для счета, особенно лейкоцитов, удобнее пользоваться камерой Предтеченского-Ключарева.

Вычисление производится аналогично подсчету эритроцитов. Предположим, что в 25 больших квадратах или 400 (25  $\times$  16) малых было сосчитано 74 лейкоцита. На один малый квадрат приходится

1 лейкоцит. Полагая, что объем одного малого квадрата равен  $\frac{1}{4000}$  мм<sup>3</sup>, кровь для счета лейкоцитов была разбавлена в 10 раз,

получим количество лейкоцитов в 1 мм<sup>3</sup>:

$$* 74 \times 4000 \times 10$$

$$400 \quad 74 \times 10 \times 10 = 7400.$$

Практически следует к сосчитанному числу лейкоцитов прибавить два нуля.

Приготовление мазков крови и их окраска. Делают укол в палец, как было указана выше, и к выступившей капле, не касаясь пальца, прикладывают предметное стекло с какого-либо одного края. После этого стекло поворачивают каплей вверх и берут его между первым и третьим пальцем левой Руки. Первым и третьим пальцем правой руки берут покровное

стекло, приставляют его плотно ребром к предметному стеклу, приблизительно под углом в 45°, подводят к капле крови и после того, как кровь распределится вдоль ребра покровного стеклышка, быстро проводят им по предметному стеклу. Мазок можно производить не покровным стеклышком, а предметным, но только шлифованным. В таком случае желательно предварительно обломать угол стеклышка, чтобы мазок был меньше ширины стекла (по середине стекла), — получается тонкий равномерный мазок крови. Через 5—10 минут он высыхает.

**Приготовление толстой капли.** На предметное стекло берут большую каплю крови, размазывают ее иглой до величины серебряного гривенника и кладут стекло вверх кровью, чтобы капля высохла.

Когда кровь подсохла, мазок фиксируют (закрепляют). Для фиксации удобнее всего пользоваться метиловым спиртом; можно фиксировать и денатурированным спиртом. Предметные стекла складывают попарно мазками наружу и ставят стаканчик (кюветку) наклонно. Препараты держат в метиловом спирту от 3 до 5 минут, а в денатурированном — 10 минут, после чего их вынимают пинцетом, промывают дистиллированной водой и ставят вертикально, чтобы дать высохнуть. Препарат с толстой каплей не фиксируют.

Затем приступают к окраске мазков. Наиболее простой и дающей очень хорошие результаты является краска Романовского-Гимза, которая состоит из двух красок: красной — эозина (кислая краска) и синей — азура (основная краска). Перед окраской готовую краску Романовского-Гимза разбавляют дистиллированной водой из расчета одна капля краски на 1 мл воды и встряхивают, чтобы получился равномерный раствор. На стекло наливают приготовленную заранее краску Романовского-Гимза таким образом, чтобы она тонким слоем покрыла весь препарат, но не стекала с краев. Окрашиваются препараты приблизительно в течение 20—25 минут, после чего краска смывается дистиллированной водой. Окраску и промывку препарата с толстой каплей нужно производить очень осторожно, потому что нефиксированная толстая капля легко смывается водой или раствором краски.

Эритроциты окрашиваются эозином в розовый цвет. Лейкоциты окрашиваются по-разному, причем ядра имеют всегда сходство к основным краскам, а потому окрашиваются в темный цвет, протоплазма же окрашивается различно в зависимости от вида лейкоцитов. Ядра лимфоцитов окрашиваются в темнофиолетовый цвет, а тонкий слой протоплазмы — в сине-голубой. Ядра моноцитов обыкновенно окрашиваются не так интенсивно, как ядра лимфоцитов, протоплазма моноцитов синевато-серого цвета. Кроме того, моноциты отличаются от лимфоцитов тем, что у первых слой протоплазмы значительно шире, ядро расположено эксцентрично и имеет неправильные контуры. В протоплазме моноцитов иногда наблюдаются включения в виде отдельных зернышек красновато-фиолетового цвета. Нейтрофилы имеют несколько ядер (сегментов), соединенных между собой очень тонкими нитями, которые окрашиваются в темнофиолетовый цвет; мелкие зернышки протоплазмы окрашиваются одинаково как эозином, так и азуром, а потому принимают

фиолетовый цвет. Протоплазма нейтрофилов как бы нейтральна к обоим краскам, почему эти клетки и получили название нейтрофилов. Зерна протоплазмы эозинофилов крупнее зерен нейтрофилов и окрашиваются исключительно эозином в яркокрасный цвет; отсюда эти клетки и получили название эозинофилов. Базофилы состоят из лопастного ядра и крупных зерен, которые красятся главным образом основными красками (азуром), а потому и ядро, и зерна окрашиваются в темнофиолетовый цвет. Кровяные пластинки (тромбоциты) окрашиваются в фиолетовый цвет.

Окрашенные мазки крови лучше всего рассматривать под микроскопом с масляной иммерсией.

**Лейкоцитарная формула** (процентное отношение разных видов лейкоцитов к общему их числу).

**Лейкоцитарная формула нормальной крови:** лимфоцитов — 20—25%, моноцитов — 4—6%, нейтрофилов — 55—65%, эозинофилов — 2—4%, базофилов — 0—1%. Эта формула показывает, что у здорового человека с нормальным составом крови она в известных пределах может видоизменяться. В патологических же случаях лейкоцитарная формула может значительно меняться независимо от общего количества белых кровяных телец.

При лейкоцитозе обычно наблюдается не равномерное увеличение всех видов лейкоцитов, а увеличение только одного или 2—3 видов, количество же других видов лейкоцитов может даже уменьшаться. Соотношение отдельных элементов формулы при многих, особенно инфекционных, болезнях довольно постоянно для данной болезни. Так, для туберкулеза характерно увеличение лимфоцитов. Увеличение количества эозинофилов наблюдается при различных гельминтозах, при бронхиальной астме. Малярия сопровождается увеличением числа моноцитов. При крупозном воспалении легких и всевозможных септических (гнойных) заболеваниях наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз, т. е. лейкоцитоз за счет увеличения нейтрофилов.

**Определение скорости оседания эритроцитов (РОЭ)** производят в приборе Панченкова, который представляет собой деревянный штатив определенной величины со вставленными в него строго вертикально специальными пипетками, удерживаемыми пружиной; кончик пипетки упирается в кусочек мягкой резины. Набирают в пипетку 5% раствор лимоннокислого натрия до метки 50, выдувают его в солонку; из укола пальца набирают крови до верхней метки (всю пипетку) и выдувают ее в ту же солонку. Таким способом набирают кровь 2 раза. Хорошо перемешав кровь с лимоннокислым натрием, набирают полную пипетку смеси и ставят в штатив, отметив время. Эритроциты оседают, и над ними остается прозрачный желтый слой плазмы. Ровно через час отсчитывают количество делений (в миллиметрах) сверху от уровня плазмы до уровня кровяного столбика. Для более четких результатов запись ведут каждые 15 минут, ибо интенсивность оседания все время меняется, особенно при заболеваниях. У здоровых мужчин (взрослых) РОЭ равна 8 мм в час, у женщин — 10 мм; она ускорена у детей,

у беременных, при воспалительных и гнойных процессах, при острых инфекционных заболеваниях, при туберкулезе и других заболеваниях; замедлена при желтухе и некоторых других болезнях.

**П а р а з и т ы к р о в и .** Спирохеты возвратного тифа (спирохета Обермейера) находятся в крови больных возвратным тифом во время приступа, появляясь за несколько часов до начала лихорадки. Окрашивать препарат крови можно по способу Рома-иовского-Гимза, но еще проще раствором карболового фуксина (краска Циля) в течение 5 минут; затем краску смывают дистил-лированной водой. Эритроциты и лейкоциты окрашиваются фуксином в красный цвет; в такой же цвет окрашиваются и спирохеты, которые имеют вид спиралеобразно завитых тонких нитей, свободно плавающих в крови.

Для открытия малярийных плазмодиев лучшим способом является окраска по Романовскому-Гимза, но препарат следует держать в краске дольше обычного — до 45—60 минут. В начале лихорадки в эритроцитах находят молодые формы плазмодиев в виде небольшого комочка или кольца, состоящего из слоя протоплазмы, окрашенного в голубой цвет, и красно-фиолетового ядра. Затем количество протоплазмы увеличивается, появляются отростки разной формы. По мере созревания плазмодий принимает округлую форму и заполняет почти весь эритроцит, который увеличивается в 1%—2 раза. Количество пигмента в паразите становится больше, причем он разбросан по всей клетке. После этого пигмент собирается в комочек с края клетки, а сам паразит начинает делиться: это новые молодые паразиты (мерозонты). Каждая форма малярии имеет своего возбудителя. Различают 3 вида плазмодия: трехдневной лихорадки, четырехдневной и тропической малярии. Молодые формы плазмодиев всех трех видов имеют форму кольца, причем при тропической малярии иногда в одном эритроците находится по два и даже по три кольца. Количество мерозонтов бывает различно: в плазмодии трехдневной лихорадки — 15—25 мерозонтов, четырехдневной — 6—8 и тропической — % 15—25 мерозонтов. При четырехдневной лихорадке зрелые формы принимают не округлую, а лентовидную форму. Если болезнь продолжается долго, то в крови появляются половые формы плазмодиев, называемые г а м е т а м и . Гаметы имеют овальную форму, свободно плавают в крови или окружены тонким слоем эритроцита.

При тропической малярии гаметы имеют своеобразную полукруглую форму.

**ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ.** Р е а к ц и я м о ч и у здорового человека должна быть кислой или слабокислой. Ее определяют лакмусовой бумажкой. Для определения реакции мочи пинцетом захватывают за один конец синюю лакмусовую бумажку, а другой конец опускают в мочу. Если бумажка покраснеет, значит моча кислой реакции, если же цвет бумажки не изменится, то реакция может быть нейтральной или щелочной. Тогда таким же образом опускают в мочу красную бумажку: если она посинеет, то моча щелочная, если останется без изменений, значит реакция нейтральная.

• **У д е л ь н ы й в е с м о ч и .** Средний удельный вес нормальной мочи равен 1 015—1 010. Для определения удельного веса наливают мочу в достаточно широкий и высокий цилиндр, чтобы урометр не касался его стенок и не доходил до дна. Урометр перед опусканием в мочу должен быть сухим; опускают его медленной замечают деление на шкале, которое соответствует уровню мочи, указывающему на удельный вес. Сначала опускают в мочу урометр с делением от 1 000 до 1 025. Если шкала не доходит до уровня мочи, то значит удельный вес ее выше 1 025; тогда опускают в мочу второй урометр с делениями от 1 025 и до 1 020.

**К а ч е с т в е н н о е о п р е д е л е н и е б е л к а .** Моча должна быть прозрачной, поэтому перед исследованием ее фильтруют. Затем нужно определить реакцию мочи, так как для исследования на белок она должна быть кислой.

**П р о б а к и п я ч е н и е м .** В пробирку наливают несколько миллилитров профильтрованной кислой мочи и кипятят. Появление белых хлопьев или мути указывает на присутствие белка в моче. Если моча была нейтральной или щелочной реакции, ее предварительно подкисляют несколькими каплями 10% раствора уксусной кислоты.

**П р о б а с а з о т н о й к и с л о т о й .** В пробирку или, еще лучше, в конический сосуд наливают 2—3 мл крепкой азотной кислоты. По стенке сосуда пипеткой осторожно приливают чочу, чтобы она не смешалась с кислотой. Тогда образуется два слоя: нижний, состоящий из азотной кислоты, удельный вес которой выше удельного веса мочи, и верхний — из мочи. При наличии белка в моче на месте соприкосновения двух жидкостей образуется мутное белое кольцо, состоящее из свернувшегося белка. Если в моче мало белка, то белоз кольцо появляется на границе двух жидкостей спустя 2—3 минуты.

**П р о б а с с у л ь ф о с а л и ц и л о в о й к и с л о т о й .** К 5—10 мл кислой профильтрованной мочи прибавляют 5—10 капель 20% раствора сульфосалициловой кислоты. При небольшом количестве белка получается ясное помутнение, при большом — выпадает беловатый хлопьевидный осадок.

**К о л и ч е с т в е н н о е о п р е д е л е н и е б е л к а .** Когда установлено наличие белка в моче, приступают к количественному его определению. Для клинических целей достаточен следующий способ. Опытным путем установлено, что образование мутного кольца на месте соприкосновения мочи с азотной кислотой через 2—3 минуты показывает, что в моче содержится 0,033% белка. Если белое кольцо появляется сразу, то мочу разводят до тех пор, пока кольцо образуется только через 2—3 минуты. Число разведений умножают на 0,033; полученное произведение покажет промилльное (один на тысячу) содержание белка. Предположим, что при 10-кратном разведении мутное кольцо образовалось через 2½ минуты; белка в данной моче будет 0,033 X 10 = 2,64‰.

**К а ч е с т в е н н о е о п р е д е л е н и е с а х а р а .** Для определения сахара чаще всего употребляется р е а к ц и я Н и -

<sup>1</sup> Иногда муть плохо отфильтровывается. Если это зависит от уратов, то мочу подогревают до исчезновения мути. При мути, вызванной бактериями, мочу нужно взболтать с инфузурной землей или йженой магнезией.

ландера, которая проводится с одноименным реактивом. Если моча содержит белок, то профильтрованную мочу слегка подкисляют уксусной кислотой, добавляют поваренной соли и кипятят. Полученный осадок белка отфильтровывают и затем в фильтрате определяют присутствие сахара. К 5—10 мл фильтрованной мочи прибавляют 1—2 мл реактива Ниландера и кипятят 2 минуты. При наличии сахара осадок, а также вся жидкость темнеют, принимают коричневый, а затем и черный цвет.

**Количественное определение сахара.** Для определения количества сахара в моче нужно брать всю суточную мочу, так как важно знать не количество сахара в данной порции мочи, а количество его, выделенное больным в течение суток. Отдельные порции мочи, взятые в разное время суток (дневная или ночная порция), могут содержать различное количество сахара.

Сначала измеряют суточное количество мочи, а затем приступают к определению количества сахара.

Наиболее быстрым и простым способом определения количества сахара является поляризационный метод, который в настоящее время применяется почти везде. Моча должна быть кислой реакции, совершенно прозрачной и по мере возможности обесцвеченной. Ее подвергают фильтрованию, подкисляют уксусной кислотой, если она щелочная, и в случае надобности обесцвечивают. Для этого прибавляют на 50 мл мочи чайную ложку уксуснокислого свинца (свинцового сахара), после чего мочу снова фильтруют. Обесцветить мочу можно также несколькими граммами животного угля, для чего нужно взболтать мочу с углем и затем профильтровать.

Вся посуда, в которой производят растворение свинцового сахара, должна быть абсолютно сухой, так же как трубка и стеклышки поляризационного аппарата. Если посуда мокрая, то ее нужно ополоснуть\* дистиллированной водой, так как с водопроводной водой свинцовый сахар дает муть. При фильтровании, несмотря на все предосторожности, первые капли обычно бывают мутными, поэтому их рекомендуется не спускать в тот сосуд, который приготовлен для фильтрата. Если моча содержит белок, то нужно перед исследованием освободить мочу от него, так как белок вращает плоскость поляризации влево и своим присутствием может извратить результаты исследования.

Трубку поляризационного аппарата наливают доверху, закрывают ее приложенным круглым стеклом, надвигая стекло сбоку так, чтобы в трубке совершенно не было пузырьков воздуха. Затем трубку закручивают металлическим колпачком и вставляют в желобок аппарата. Если моча содержит сахар, то в трубку поляризационного аппарата ясно видно, что правая половина поля зрения будет темнее левой. Вращая винт, нужно выровнять освещение обеих половин поля зрения. Шкала укажет степень отклонения поляризованного луча, которое соответствует определенному количеству процентов сахара, что и значится на шкале.

**Определение желчных пигментов.** В конический стаканчик или пробирку наливают 5—10 мл профильтрованной кислой мочи, свободной от белка. Если моча щелочная,

то ее предварительно подкисляют несколькими каплями 10% уксусной кислоты. На мочу осторожно настилают по стенке стаканчика 1% спиртовой раствор иода. Реакция будет положительной, если на месте соприкосновения двух жидкостей образуется желтое кольцо. 1% спиртовой раствор иода готовится перед началом реакции путем смешения 1 мл йодной настойки (10% спиртовой раствор иода) с 9 мл 95% алкоголя.

**Определение уробилина:** к 10 мл мочи прибавляют столько же миллилитров хорошо взболтанного 10% спиртового раствора хлористого цинка, затем мочу фильтруют; при рассматривании фильтрата ясно видна зеленая флюоресценция.

**Микроскопическое исследование мочевого осадка.** Мочевой осадок получает центрифугированием. После центрифугирования жидкость из стеклянной пробирки сливают, осадок достают пипеткой и выпускают на предметное стекло одну не слишком большую каплю, которую прикрывают покровным стеклом. Покровное стекло подводят к капле сбоку под углом в 45°. Когда жидкость распределится по ребру покровного стекла, его медленно опускают на каплю, чтобы под стеклом не образовалось пузырей воздуха. Препарат рассматривают под микроскопом.

**Неорганизованные осадки мочи.** Мочение льется соли имеют вид мелких зернышек, окрашенных в желтый цвет. Мочевая кислота выпадает в виде кристаллов различной формы, желтобурого цвета, которые под микроскопом имеют вид ромбических табличек, брусков, бочонков, щеток, песочных часов и т. п.

**Щавелевокислая известь, или оксалат,** имеет вид квадратных кристаллов, похожих на конверты.

В щелочной моче чаще встречается фосфорнокислая аммиак-магnezия, мочеислый аммоний, аморфные фосфаты.

**Фосфорнокислая аммиак-магnezия** (трипельфосфат) имеет вид бесцветных кристаллов в форме трех- или шестиугольных призм, похожих на гребенчатые крышки.

Кристаллы мочеислого аммония имеют вид желто-бурых шаров с отростками и шипами.

**Аморфные фосфаты** (фосфорнокислая известь, фосфорнокислая магnezия) по внешнему виду очень сходны с уратами: они тоже состоят из мелких зернышек и шариков, часто собранных в кучки. От уратов они отличаются тем, что бесцветны и находятся только в щелочной моче.

**Организованные осадки мочи** состоят из элементов, поступающих в мочу из крови, почечной ткани и моче выводящих путей: эпителиальные клетки, спущенные со слизистой оболочки мочевого выводящих путей, клетки почечных канальцев, все возможные цилиндры, эритроциты, лейкоциты, бактерии. Лейкоциты и эпителиальные клетки мочевого выводящих путей и наружных половых органов в небольшом количестве находятся и в нормальной моче. Клетки почечного эпителия и цилиндры наблюдаются только в патологической моче и главным образом при воспалении почек.

Эпителий мочевыводящих путей состоит из многоугольных, кругловатых больших клеток неправильной формы с одним маленьким ядром и зернистой протоплазмой. Некоторые клетки могут быть удлинёнными, с отростками, откуда получают название хвостатых клеток. Большое количество их может вызвать подозрение на поражение почечных лоханок.

Клетки почечного эпителия являются клетками почечных канальцев и находятся в моче только при воспалении почек. Они немного больше лейкоцитов, многоугольной или круглой формы, имеют сравнительно большое ядро.

Лейкоциты — гнойные тельца, имеющие форму небольших зернистых шариков, которые отличаются от клеток почечного эпителия меньшей величиной и отсутствием ядра.

Эритроциты меньше лейкоцитов, слабо окрашены в желтый цвет и имеют форму дисков с вдавлением в середине. Сбоку эритроциты имеют вид бисквитов. Красные кровяные тельца, потеявшие красящее вещество, называются выщелоченными эритроцитами.

Цилиндры эпителиальные представляют собой как бы трубку из клеток слущенного эпителия мочевого канальца; клетки этих цилиндров будут несколько меньших размеров, чем отдельные клетки почечного эпителия, свободно плавающие и разбухшие в моче.

Цилиндры зернистые являются дегенеративно перерожденными эпителиальными цилиндрами, состоящими из зернышек — продуктов распада клеток почечного эпителия.

Цилиндры гиалиновые, возможно, представляют собой дальнейшее изменение зернистых цилиндров. Они бледны с неясно очерченными контурами, однородные по своему строению, часто с, наложенными клетками почечного эпителия, лейкоцитами или эритроцитами.

Цилиндры восковидные — большие, широкие и резко ограниченные, с восковым блеском, имеют поперечные перехваты. Предполагают, что они образуются из перерожденных эпителиальных цилиндров, долгое время находящихся в почечных канальцах.

Микробы. Препарат всегда следует тщательно просмотреть с целью обнаружения микробов. При необходимости их окрашивают специальными красками для определения их вида.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО.**  
Определение общей кислотности, т. е. суммы всех кисло реагирующих веществ, куда входит свободная соляная кислота, связанная соляная кислота и различные органические кислоты. Исследование производят путем титрования профильтрованного желудочного сока децинормальным раствором едкого натра. По количеству щелочи, пошедшей на нейтрализацию, судят о степени общей кислотности и количестве свободной, а также связанной соляной кислоты. 10 или 5 мл профильтрованного желудочного содержимого наливают в стаканчик или маленькую колбочку, куда прибавляют в качестве индикатора 1—2 капли 1% спиртового раствора фенолфталеина, который в кислой среде бес-

цветен, а в щелочной становится яркокрасным. Из бюретки в колбочку по каплям осторожно прибавляют децинормальный раствор едкого натра, все время слегка взбалтывая ее до появления бледно-розового окрашивания, что является концом реакции. Высчитывают, сколько миллилитров едкого натра пошло на нейтрализацию всех кислот желудочного содержимого. Полученное число умножают на 10, чтобы определить количество децинормального раствора едкого натра, необходимого для нейтрализации 100 мл желудочного содержимого. Предполагая, что на 10 мл желудочного сока пошло 4,8 мл титрованного раствора, или 48 мл на 100 мл. Значит, общая кислотность в данном желудочном содержимом будет равна 48. Если титровали 5 мл желудочного сока, то количество титрованного раствора, пошедшего на нейтрализацию, нужно помножить не на 10, а на 20. Общая кислотность желудочного сока в норме колеблется в пределах от 40 до 60.

Определение свободной соляной кислоты. В качестве индикатора применяют диметиламидазобензол, который в присутствии свободной соляной кислоты из желтого становится яркокрасным: берется 10 или 5 мл профильтрованного желудочного содержимого, куда прибавляют 1—2 капли диметиламида-азобензола. Титрование продолжают до тех пор, пока красный цвет содержимого не начнет переходить в желтый. Полученное количество миллилитров умножают на 10 или 20 и получают число миллилитров децинормального раствора едкого натра, необходимого для связывания всей свободной соляной кислоты в 100 мл желудочного содержимого. Свободной соляной кислоты в нормальном желудочном соке содержится 20—40.

Одновременное определение общей кислотности и свободной соляной кислоты. К 10 мл профильтрованного желудочного содержимого сразу прибавляют оба индикатора: фенолфталеин и диметиламидазобензол. От присутствия последнего содержимое окрасится в красный цвет.

Титрование продолжают до перехода красного цвета в красновато-желтоватый, т. е. до момента нейтрализации свободной соляной кислоты. Число миллилитров раствора, пошедшего на связывание свободной соляной кислоты, укажет на ее количество. Затем продолжают титрование до перехода бесцветного фенолфталеина в розовый цвет. Общее количество миллилитров децинормального раствора едкого натра, необходимое для окончания всей реакции, определит общую кислотность.

Определение связанной соляной кислоты. Титруют 5 или 10 мл профильтрованного желудочного содержимого децинормальным раствором едкого натра. Индикатором служит 1% водный раствор ализарина (2—3 капли). Конец реакции определяется по появлению фиолетовой окраски в испытуемой жидкости. Ализарин реагирует со всеми кислотными соединениями, за исключением связанной соляной кислоты. Чтобы определить количество связанной соляной кислоты, нужно из числа, опре-

деляющего общую кислотность, вычсть число, полученное при титровании с ализарином.

**Молочная кислота.** В патологических случаях в желудочном содержимом находятся органические кислоты: молочная, уксусная и масляная. Наибольшее клиническое значение имеет присутствие молочной кислоты, которая образуется в результате молочнокислого брожения углеводов, вызванного особыми молочнокислыми палочками. Молочная кислота часто появляется при раке желудка, когда отсутствует соляная кислота.

**Определение молочной кислоты:** к 15—20 мл 1% раствора карболовой кислоты прибавляют одну каплю полуторахлористого железа, вследствие чего раствор приобретает темнофиолетовый цвет. Полученную смесь разбавляют дистиллированной водой до образования светлоаметинового цвета, после чего к ней прибавляют по каплям профильтрованный желудочный сок. От присутствия молочной кислоты аметиновый цвет переходит в канареечножелтый.

**Кровь** заметна макроскопически, если она имеется в значительном количестве. При небольшой ее примеси можно найти под микроскопом эритроциты, а кроме того, определить кровь при помощи реакции с бензидином или реакции Вебера. Желудочный сок должен быть нефилтрированным — см. *Исследование кала*.

**Микроскопическое исследование** желудочного содержимого. Для приготовления неокрашенного препарата желудочного содержимого ему дают предварительно отстояться, со дна сосуда пипеткой достают небольшое количество осадка, наносят на предметное стекло и покрывают покровным. Микроскопическое исследование начинают с малого увеличения и затем переходят к большему.

После пробного завтрака по Боас-Эвальду в нормальном желудочном содержимом находят довольно большое количество крахмальных зерен в различной степени переваривания, единичные дрожжевые клетки, плоский эпителий из полости рта и единичные растительные клетки.

**Крахмальные зерна** имеют вид слоистых шарообразных и овальных образований различной величины, находящихся в различных стадиях переваривания.

**Плоский эпителий** из полости рта состоит из больших неровных клеток с небольшим ядром.

**Клетки цилиндрического эпителия** сравнительно небольшие, удлинённые.

**Жир** встречается в виде блестящих шаров в норме в единичных экземплярах.

**Дрожжевые грибки** часто соединяются группами в виде цепочек или виноградных кистей. При процессах брожения количество их может быть значительным.

**Растительные клетки** обычно больших размеров, своеобразного строения, встречаются как в нормальном, так и в патологическом желудочном соке.

В желудочном содержимом, в котором находятся остатки пищи с предыдущего дня, могут попадаться мышечные волокна с поперечной полосатостью.

**Лейкоциты** находятся в желудочном соке при различных воспалительных процессах в слизистой оболочке; особенно много их при гнойных воспалениях. Обычно лейкоциты сильно изменены, встречаются чаще одни ядра, без протоплазмы, которая растворяется желудочным соком.

**Эритроциты** неизменные говорят о недавнем кровотечении.

**Сарцины** — особый вид грибов, имеющих форму перевязанных туюков; развиваются при хронических катаррах желудка, при его расширении, когда застывает желудочное содержимое.

Большое диагностическое значение имеет присутствие **молочнокислых палочек**, вызывающих молочнокислое брожение с образованием молочной кислоты. Молочнокислые палочки появляются только при отсутствии соляной кислоты. Они довольно большой величины, неподвижны, с закругленными краями, расположены часто под углом одна к другой. Молочнокислые палочки достаточно хорошо видны на свежем препарате без окраски.

В патологическом желудочном содержимом часто находится **слизь**, которая в большом количестве выделяется слизистой оболочкой при ее катарре (воспалении). Слизь имеет вид тонких, мало заметных волокнистых, продольно исчерченных полосок.

**ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА.** Кровь в большом количестве настолько изменяет внешний вид кала, что ее можно определить без всяких исследований. Для определения крови химическим путем пользуются реакцией Вебера. Ее применяют и для нахождения крови в моче и желудочном содержимом. Небольшое количество кала, взятое из разных мест всей его массы, растирают с водой, а затем с несколькими миллилитрами ледяной уксусной кислоты. К полученной смеси прибавляют  $\frac{1}{4}$  объема эфира, закрывают пробирку или цилиндр и несколько раз опрокидывают, чтобы извлечь кровяной пигмент. После этого эфирную вытяжку как более легкую сливают в чистую пробирку, куда приливают 5—10 капель алкогольного раствора гваяковой смолы и 20 капель озонированного скипидара. От присутствия крови жидкость окрашивается в синий цвет.

Более чувствительна и проста реакция с бензидином. На предметном стекле размазывают тонким слоем кусочек кала и на него наносят 2—3 капли следующего реактива: 0,025 г бензидина, растворенного в 2,5 мл ледяной уксусной кислоты и смешанной с 2,5 мл 3% перекиси водорода (вместо перекиси водорода употребляют еще перекись бария). В присутствии крови появляется темнозеленое или синее окрашивание.

Многие составные части кала бывают настолько измельчены или микроскопически малы, что при самом тщательном макроскопическом исследовании обнаружить их не удастся. Если кал твердый, то небольшой кусочек его или несколько кусочков, взятых из разных мест, растирают с физиологическим раствором поваренной соли или дистиллированной водой. Каплю приготовленного таким образом кала стеклянной палочкой наносят на предметное стекло и осторожно накладывают сверху покровное. Если кал полужидкий или жидкий, то его непосредственно наносят на стекло



для исследования. Нужно следить за тем, чтобы слой не был слишком густым. Очень жидкий кал следует центрифугировать и исследовать полученный осадок.

**Мышечные волокна** находятся в нормальном кале, если человек потребляет большое количество мяса. Значительное количество мышечных волокон против нормы указывает на плохое переваривание, т. е. на катарр тонких кишок или на заболевание поджелудочной железы. Мышечные волокна неправильной формы, часто окрашены желчью в желтый цвет; для них очень характерна поперечная полосатость.

**Соединительная ткань** беловато-сероватого цвета, волокнистого строения, встречается в большом количестве при недостаточном желудочном пищеварении.

**Жир** находится в виде блестящих круглых капель при нарушении перевариваемое™ жиров от отсутствия желчи или заболевания поджелудочной железы.

**Крахмальные зерна** всегда говорят о поражении тонких кишок.

**Растительные клетки** различной величины и формы встречаются и в нормальном кале при употреблении растительной пищи (овощей, фруктов и ягод).

**Клетки эпителия**, преимущественно цилиндрического в большом количестве встречаются при воспалении слизистой оболочки кишок.

**Эритроциты** неизменные находятся в испражнениях только при кровотечениях из нижних отрезков кишок, например, при геморрое.

**Лейкоциты** в кишечнике распадаются и под микроскопом не обнаруживаются. Лишь при воспалительном процессе (особенно гнойном) в нижнем отделе толстых кишок или прямой кишке находятся перерожденные или даже неизменные белые кровяные тельца.

**Яйца аскарид** имеют овальную, почти круглую форму, желто-коричневого цвета, покрыты плотной неровной оболочкой и состоят из мелкозернистой массы.

**Яйца власоглава** овальные, с крышечками на концах, покрыты оболочкой и тоже с зернистым содержимым.

**Яйца остриц** овальной формы, с крупнозернистой серединой, покрыты двойной оболочкой.

**Яйца свиного солитера** имеют круглую форму, покрыты исчерченной оболочкой, внутри находятся крючья зародыша.

**Яйца бычьего солитера** настолько сходны с яйцами свиного солитера, что по ним нельзя различить эти два вида солитеров.

**Яйца широкого лентеца** овальной формы, покрыты оболочкой. Яйцо состоит из кружков почти равной величины; на одном его конце находится крышечка, которая открывается при выходе зародыша.

**Макроскопическое исследование кала на глистов.** Рассматривая кал, нужно всегда обращать внимание,

не находятся ли в нем глисты, их обрывки или отдельные членики. Круглые глисты, даже маленькие острицы, легко обнаруживаются в кале. Ленточные глисты редко самостоятельно выделяются из кишечника. В кале находят обыкновенно оторвавшиеся части большей или меньшей длины, а также отдельные членики. Часто обрывки и хлопья слизи принимают за ленточных глистов. По найденным членикам можно сказать, какой вид глистов обитает в человеке. Чтобы точно сказать, какому солитеру принадлежат членики, нужно рассмотреть их строение. Членик кладут между предметными стеклами, раздавливают его, смотрят на свет, и тогда ясно обозначается ветвистое строение членика, имеющего матку, наполненную яйцами. У свиного солитера матка состоит из 7—10 довольно толстых разветвлений. Членик бычьего солитера значительно больше свиного; матка состоит из 20—30 более тонких веточек и имеет боковой выводной проток. Членики широкого лентеца более короткие и широкие: в середине их находится матка в виде темной розетки.

**ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ.** Микроскопический вид мокроты на неокрашенном препарате. Выбирают из мокроты предварительно прокаленной лопаточкой или платиновой петлей маленькие зернышки или комочки зеленоватого или желто-белого цвета и кладут на середину заранее приготовленного предметного стекла. Взятые части мокроты, не размазывая, покрывают покровным стеклом, которое прижимают ручкой лопаточки так, чтобы все содержимое распределилось тонким равномерным слоем. Под микроскопом мокрота представляется в виде слизистой массы неопределенного строения, в которой разбросаны различные форменные элементы.

**Клетки плоского эпителия** большие, многоугольные, с небольшим ядром. Значительное количество таких клеток говорит о воспалительном процессе в верхних дыхательных путях. Иногда при тяжелом поражении бронхов в мокроте находят цилиндрические клетки мерцательного эпителия продолговатой формы с вытянутым концом.

**Альвеолярный эпителий** состоит из круглых клеток с довольно большим круглым ядром; встречается при многих легочных заболеваниях. Иногда его находят в большом количестве в мокроте туберкулезных больных.

**Форменные элементы крови** — эритроциты и лейкоциты — в единичных экземплярах находятся во всякой мокроте. Если в мокроте имеется значительная примесь крови, то эритроциты складываются в «монетные столбики» и могут покрывать все поле зрения. Лейкоциты в небольшом количестве попадают в серозной и слизистой мокроте. Гнойная мокрота сплошь состоит из лейкоцитов. В мокроте встречаются лейкоциты всех видов. При некоторых заболеваниях преобладают одни виды, при других — другие.

**Эластические волокна** являются составной частью легочной ткани, и нахождение их в мокроте говорит о распаде легочной ткани. Чаще всего эластические волокна наблюдаются при туберкулезе, а также при абсцессе и гангрене легких. Они имеют вид блестящих ветвящихся нитей с двойным контуром, которые

в большинстве случаев располагаются пучками, сохраняя форму легочных альвеол.

Чтобы найти эластические волокна, когда их немного, берут 4—6 мл мокроты, прибавляют такое же количество 10% раствора едкого кали и нагревают до кипения, пока не растворится мокрота. Затем к жидкости прибавляют несколько капель 1% спиртового раствора эозина и центрифугируют ее. В капле осадка под микроскопом видны блестящие эластические волокна, окрашенные в оранжево-красный цвет.

Спирали Куршмана имеют вид спирально извитых тонких нитей, которые встречаются чаще всего при бронхиальной астме.

Кристаллы Шарко-Лейдена имеют вид блестящих бесцветных кристаллов, встречающихся в комочках мокроты чаще всего вместе со спиралью Куршмана.

Кристаллы попадают поодиночке, а при большом их количестве слагаются в кучки. Чаще всего кристаллы Шарко-Лейдега встречаются при бронхиальной астме. Иногда их находят при бронхитах и туберкулезе легких.

**Приготовление мазка.** Выбирают из различных мест мокроты отдельные комочки и частицы, кладут их на предметное стекло, покрывают другим предметным стеклом и несколько раз раздвигают для получения тонкого мазка. После этого препарат должен совершенно высохнуть на воздухе, иначе при дальнейшей обработке белок мокроты свернется.

**Фиксация препарата.** Сухие мазки мокроты фиксируют на пламени горелки, быстро проводя предметные стекла 3—4 раза над огнем, причем слой мокроты должен быть обращен вверх. Фиксировать нужно очень тщательно: если фиксирование произведено недостаточно, то при окраске мокрота смывается; при чрезмерной фиксации на огне мокрота обуглится, и препарат будет испорчен.

**Окраска метиленовой синькой или фуксином.** На приготовленный и зафиксированный препарат наливают краску на 2—3 минуты так, чтобы она покрыла все стекло, но не перелилась через края. Затем краску смывают дистиллированной водой, препарат высушивают и кладут под микроскоп для осмотра.

**Окраска по Граму.** Сначала препарат в течение 2—4 минут окрашивают карболовым раствором генцианвиолета, наливая краску на фиксированный препарат, покрытый фильтровальной бумагой, затем опускают на 1—2 минуты в люголевскую жидкость, после этого обесцвечивают в чистом спирите, пока препарат не станет бледносерым. По окончании окраски препарат обмывают дистиллированной водой, высушивают и исследуют под микроскопом. Бактерии окрашиваются по Граму в сине-фиолетовый цвет. Чтобы они ярче выступали после окраски, препарат красят какой-либо дополнительной краской, например, разведенным фуксином  $V_3$ —1 минуту. Тогда сине-фиолетовые бактерии

Л Раствор Люголя: йода кристаллического  $i$  г, йодистого калия 2 г, воды дистиллированной 300 л.

ясно выступают на красном фоне. Бактерии, красящиеся по Граму, называются грамположительными, а не красящиеся — грамотрицательными. К грамположительным бактериям относятся: диплококки Френкеля, стрептококки, стафилококки, туберкулезные палочки, дифтерийные и др., а к грамотрицательным — гонококки, палочки Фридлендера, инфлюэнцы, тифозные и др.

Гноеродные бактерии — стрептококки — имеют вид цепочек, круглые кокки — стафилококки — соединяются в виде гроздей винограда. Гноеродные бактерии наблюдаются при гнойных заболеваниях легких, например, при их абсцессе, а также и при других легочных заболеваниях: бронхитах, воспалении легких, туберкулезе.

Диплобациллы Фридлендера (пневмобациллы) — довольно толстые, короткие палочки, расположенные попарно и заключенные в капсулу. Они в большом количестве наблюдаются при воспалении легких, а кроме того, бывают и при других легочных заболеваниях.

Диплококки Френкеля (пневмококки), окрашенные по Граму, имеют вид двойных удлинненных кокков, окруженных бесцветной капсулой. Концы диплококков, обращенные друг к другу, закруглены, а противоположные заострены. Диплококки Френкеля являются возбудителями крупозного воспаления легких, хотя иногда встречаются и при других легочных заболеваниях.

**Туберкулезные палочки** (окраска по способу Циля-Нильсена). На приготовленный и зафиксированный препарат мокроты, удерживаемый пинцетом, кладется полоска фильтровальной бумаги, величина которой должна быть меньше предметного стекла. Поверх бумаги наливают краску Циля (карболовый раствор фуксина) в таком количестве, чтобы она не перелилась через край стекла. Затем снизу подогревают стекло на горелке до образования паров (но не до кипения), после чего пинцетом снимают фильтровальную бумагу, смывают дистиллированной водой излишек красящего вещества и помещают препарат в 25% раствор серной кислоты, в котором держат его до обесцвечивания. Затем его переносят для дополнительного обесцвечивания на несколько минут в чистый спирт; наконец, обмывают дистиллированной водой, высушивают и исследуют. На бесцветном фоне выступают окрашенные фуксином в красный цвет туберкулезные палочки. Чтобы они были видны яснее, препарат после обесцвечивания серной кислотой и обмывания водой окрашивают дополнительно в течение 2—1 минуты раствором метиленовой синьки. После этого остаток краски смывается дистиллированной водой, препарат высушивают, и под микроскопом видны красные туберкулезные палочки на синем фоне.

**ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛЕТОВ.** Приготовление мазка, фиксация и окраска. Для микроскопического исследования полученного материала вынимают тампон из пробирки и размазывают его по абсолютно чистому предметному стеклу. Если удалось с налета снять пленку, то ее стараются целиком нанести на стекло. Препарат высушивают и красят так же, как препараты с мокротой. Обыкновенно красят разведенным раствором Циля



с горячей водой, растирают кожу щетками. При ослаблении сердца впрыскивают <sup>^</sup>камфору, кофеин, стрихнин.

**МОЛНИЕЙ ПОРАЖЕНИЕ** сходно с поражением электрическим током чрезвычайно большой частоты и напряжения. В тяжелых случаях наступает моментальная смерть. На коже появляются характерные полосы красного цвета (местный паралич сосудов) зигзагообразной формы с разветвлениями (рисунки молнии). На местах входа и выхода молнии края кожи обожжены. Симптомы поражения и меры помощи см. *Электрическим током поражение*.

**ОБМОРОК.** Потеря сознания при обмороке происходит вследствие быстро наступившей анемии мозга. Причиной обморока бывают большие потери крови, переутомление, голодание, продолжительное стояние на ногах, особенно в душном помещении, быстрый переход слабого больного из лежачего положения в сидячее или стоячее. Обморок может наступить от боли, при различных внезапных и сильных переживаниях (страх, неожиданное неприятное известие и пр.), вследствие чего рефлекторно происходит спазм кровеносных сосудов мозга. Перед обмороком часто появляется головокружение, общая слабость, тошнота.

Обморок характеризуется побледнением кожных покровов, губ, похолоданием конечностей; сердечная деятельность падает (коллапс), пульс едва прощупывается. Обморочное состояние иногда бывает очень кратковременным, продолжаясь всего несколько секунд; в других случаях обморок не проходит и через 5—10 минут и более. Продолжительное обморочное состояние всегда опасно для жизни больного, особенно при значительном упадке сердечной деятельности.

Во время обморока больному нужно прежде всего придать горизонтальное положение, положить его на кровать или кушетку, чтобы вызвать прилив крови к голове. Для облегчения дыхания освобождают больного от стесняющей его одежды: расстегивают или надрезают воротник, пояс, лифчик и пр. На кровати кладут больного без подушки, а иногда даже приподнимают<sup>^</sup> ноги больного или ножной конец кровати, чтобы голова была ниже ног. Если обморок случится на улице или в помещении, где не на что положить больного, его следует положить тут же на землю или на пол. Чтобы вывести больного из<sup>^</sup> обморочного состояния, иногда достаточно рефлекторного воздействия на сосудодвигательные нервы: обрызгать лицо холодной водой или дать понюхать нашатырный спирт, смочив им ватку или кончик носового платка, и медленно (не вплотную), поднося его к Носу; нашатырным спиртом натирают также виски больного.

Когда больной придет в себя, можно ограничиться дачей эфирно-валериановых капель.

При глубоком обмороке, сопровождающемся упадком сердечной деятельности, приходится впрыскивать под кожу возбуждающие средства — камфору и кофеин (см. *Сердечно-сосудистая недостаточность острая*). При всяком бессознательном состоянии, в том числе и обмороке, необходимо вынуть изо рта зубные протезы, так как снимающийся протез может запасть в глотку и пищевод.

**ПОВЕШЕНИЕ.** Петлей сдавливается дыхательное горло и крупные кровеносные сосуды шеи. Вследствие сдавления сонных артерий нарушается кровообращение мозга, наступает острая анемия мозга, и повешенные почти сразу теряют сознание. Погибают повешенные от удушья, которое наступает обычно уже в бессознательном состоянии. У повешенных на шею от петли остаются ссадины, кровоподтеки; иногда наблюдаются переломы хрящей гортани и отек окружающей ткани.

Если повешенного во-время освободить из петли, то можно вернуть его к жизни при помощи искусственного дыхания. Перерезая веревку, нужно снизу поддерживать повешенного, чтобы он не упал и не расшибся. Желая быстрее спасти повешенного, нельзя дергать его вниз, так как петля в таком случае будет еще больше затягиваться. Освободив повешенного от петли, приступают немедленно к искусственному дыханию. Затем нужно растирать его, давать нюхать нашатырный спирт; в случае надобности впрыскивают возбуждающие средства (камфору, кофеин, стрихнин). Повреждения шеи лечатся хирургическим путем.

**ПОРАЖЕНИЕ МОЛНИЕЙ** см. *Молнией поражение*.

**ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** см. *Электрическим током поражение*.

**СОЛНЕЧНЫЙ УДАР.** Продолжительное воздействие солнечных лучей на голову ведет к расширению <sup>^</sup>изговых кровеносных сосудов, вследствие чего наблюдается прилив крови к голове (гиперемия). Вследствие значительной гиперемии может развиваться воспаление мозговых оболочек или даже самого головного мозга (менингит и энцефалит). Первыми признаками солнечного удара будут покраснение лица и сильные головные боли. Затем появляется тошнота, головокружение, потемнение в глазах и, наконец, рвота. Больной впадает в бессознательное состояние, появляется одышка, падает деятельность сердца.

Профилактическими мерами является прикрытие головы шапкой, платком, а также обливание головы холодной водой. Меры помощи см. *Тепловой, удар*.

**ТЕПЛОВОЙ УДАР** (болезненное состояние, возникшее вследствие перегревания тела). Происходит тогда, когда уменьшена или задержана отдача тепла при повышенном или даже нормальном теплообразовании. Три основных фактора ведут к перегреванию тела: 1) высокая внешняя температура, 2) плотная одежда, задерживающая испарения кожи, и 3) усиленная физическая работа. Тепловые удары случаются не только в жаркую погоду, но происходят также в жарких, душных помещениях.

Тепловой удар наступит скорее всего при одновременном сочетании всех трех указанных факторов. Перегреванию тела способствует еще и недостаток питьевой воды: если человек мало пьет, то уменьшается потоотделение, при испарении же пота с поверхности тела происходит его охлаждение. При перегревании тела появляется вялость, усталость, головокружение, головная боль, сопливость. Лицо краснеет, походка делается шатающейся, дыхание затруднено, температура тела доходит до 40°. Если к этому времени не устранены причины, вызвавшие перегревание, наступает тепловой удар:

больной теряет сознание, падает, лицо становится бледным, синюшным, кожа холодная, покрытая потом, пульс нитевидный учащенный. В таком состоянии пораженный тепловым ударом может погибнуть.

С профилактической целью необходимо в душных помещениях устраивать вентиляцию. При работе или маршах под палящим солнцем необходимо периодически отдыхать в тени и во время отдыха по возможности купаться или обливаться холодной водой. Насколько возможно, нужно на это время обеспечивать людей достаточным количеством питьевой воды. Когда появились симптомы значительного перегревания тела или уже наступил тепловой удар, в первую очередь нужно вывести или вынести больного из душного помещения на свежий воздух, из-под солнечных лучей в тень, уложить, освободить от стесняющей одежды; на голову и на сердце кладут холодные компрессы, дают пить холодную воду в большом количестве, в тяжелых случаях пострадавшего обливают холодной водой. Если больной находится в бессознательном состоянии, ставят клизмы из прохладной воды, делают подкожные вливания физиологического раствора, осторожно дают нюхать нашатырный спирт. При резком ослаблении сердечной деятельности впрыскивают под кожу камфору, кофеин или стрихнин. При остановке дыхания необходимо производить искусственное дыхание.

**УДУШЕНИЕ** наступает при повешении, утоплении и от других причин, вызывающих прекращение дыхания. Непосредственным удушением или удушением называют сдавление шеи петлей или рукой. Симптомы и меры помощи при удушении те же, что и при повешении (см.). Вскоре после удушения можно привести человека в сознание и вернуть к жизни путем искусственного дыхания.

**УКУСЫ ЗМЕЙ.** При действии змеиного яда наблюдается отек места укуса, которое становится красным, болезненным, припухлым. Объем конечности через полчаса может увеличиться почти вдвое.

**Первая помощь.** Перетяжка конечности выше места укуса в течение 30 минут, постепенное снятие и переход на застойную гиперемию по Виру. Очень желательно отсасывание крови банкой (не ртом!) с предварительным расширением ранки. Никакого прижигания ранки! Производят первичное иссечение или в крайнем случае раскрытие ранки (если пострадавший тотчас после укуса доставлен в лечебное заведение). Повязка с гипертоническим раствором поваренной соли. По окружности укуса вводится специфическая сыворотка против змеиных укусов, при ее отсутствии — 1% эмульсия продажного карбонового мыла. Для иммобилизации — шинная повязка. Внутреннее вливание марганцовокислого калия. Кофеин-атронин, камфора под кожу; производят согревание больного.

**УКУСЫ НАСЕКОМЫХ.** Наиболее опасны насекомые, встречающиеся в южной полосе Советского Союза. Сюда относятся скорпион и паук кара-курт.

От укуса скорпиона наблюдается покраснение, боль и припухлость на месте укуса. Затем могут появиться явления общего отравления: судороги, рвота, ослабление пульса.

Меры помощи те же, что и при укусе змей.

При укусе кара-курта ощущается боль. На месте укуса воспалительных явлений не развивается, но яд, попадая в ток крови, вызывает общие явления отравления: общая слабость, жажда, холодный пот, ослабление сердечной деятельности. В качестве первой помощи на место укуса кладут холодные примочки, лучше из раствора марганцовокислого калия. Обильное питье, вливания физиологического раствора, сердечные средства.

Укусы южнорусского тарантула, сколопендры, паука фаланги не опасны для жизни больного. Здесь также на место укуса следует класть холодные примочки из раствора марганцовокислого калия или раствора нашатырного спирта.

**УКУСЫ ПЧЕЛ** (ОС, ШМЕЛЕЙ И ДР.). Одиночные укусы пчел никакой опасности для жизни не представляют, но вызывают резкую боль с последующим образованием отека кожи. Если в ранке осталось жало, его нужно удалить, смазать ранку нашатырным спиртом и класть холодные компрессы из раствора марганцовокислого калия. Опасны многочисленные укусы пчел: около 500 укусов считаются смертельными для человека. В этих случаях появляются признаки общего отравления: ослабление сердечной деятельности, одышка, рвота, понос, судороги и затем бессознательное состояние. Меры помощи: обильное питье, вливания физиологического раствора, сердечные средства.

**УТОПЛЕНИЕ.** Человек под водой задерживает дыхание, насколько может, а затем делает выдохательное движение, во время которого вода входит в его дыхательные пути. При последующих дыхательных движениях вода заполняет легкие и наступает 'задушение'.

Спасая тонущих, нужно соблюдать известные правила. Тонущему бросают спасательные круги, конец веревки и пр. Если этих предметов нет или тонущий впадает в бессознательное состояние, необходимо плыть ему на помощь. Спасать утопающих может только хороший пловец. Перед тем как броситься в воду, следует снять по крайней мере верхнюю одежду и особенно обувь. Подплывать к утопающему, если он еще в сознании, нужно очень осторожно, так как утопающий может схватить спасающего и потянуть его с собой на дно. Самое удобное — положить голову утопающего к себе на грудь, поддерживать его рукой и плыть на спине к берегу. Если человек тонет, провалившись под лед, то бежать к нему на помощь нельзя, так как спасающий тоже может провалиться и превратиться во второго тонущего. Поэтому тонущему нужно бросать веревку, протягивать к нему палки, багры, продвигать лестницу, доски и пр. Приближаться к утопающему спасающий должен по лестнице или доскам, наблюдая, не подламывается ли под ним лед. Если пострадавший еще жив, по находится в бессознательном состоянии (бледен, холоден, пульс едва прощупывается, глаза закрыты, дыхание отсутствует), его немедленно следует освободить от одежды, сняв ее или разрезав, очистить рот и нос платком или рубашкой от ила, песка и пр., положить животом на валик (бревно) или на колено, так, чтобы голова свешивалась вниз, и сильно нажимая на спину между лопатками, стараться удалить

воду из легких и желудка. Нужно следить за положением головы, чтобы рот и нос не были закрыты. После этого немедленно приступить к искусственному дыханию. Чтобы язык не западал, нужно его вытянуть салфеткой, носовым платком и пр. и придерживать все время, пока проводятся мероприятия по оживлению утопленника. Одновременно начинают согревать пострадавшего: растирают его щетками или жестким полотенцем, смоченным спиртом, обкладывают грелками или бутылками с горячей водой. Искусственное дыхание нельзя прекращать с первым появлением вдоха утопающего, а нужно продолжать до полного восстановления самостоятельно! о дыхания. Под кожу впрыскивают возбуждающие средства: камфору, кофеин, стрихнин. Когда пострадавший начнет дышать, ему дают нюхать нашатырный спирт. По возвращении сознания пострадавшего укладывают в теплую постель, обкладывают грелками и дают ему выпить горячий кофе или чай.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОРАЖЕНИЕ.** Ожоги у места входа и выхода тока обычно тяжелые — третьей степени. Общее действие тока большой силы и напряжения вызывает моментальную потерю сознания и смерть. Если человек случайно схватится за обнаженный электрический провод, появляются судороги в руках и пораженный током не может разжать руки и освободиться от провода. В тяжелых случаях поражения электрическим током наблюдается бессознательное состояние, холодная бледная кожа, слабый пульс, поверхностное дыхание, которое иногда может совершенно прекратиться. В первую очередь нужно освободить потерпевшего от воздействия тока, выключив ток. Если это невозможно, нужно отбросить провод, находящийся в соприкосновении с пострадавшим. При оказании помощи нужно всегда помнить, что, прикасаясь к пораженному, сам спасающий тоже может пострадать, если предварительно не был выключен ток. Поэтому при невозможности выключить ток необходимо изолировать себя или от земли, или от пострадавшего. Провод можно откинуть сухой деревянной палкой, на руки надеть резиновые перчатки, на ноги — сухие резиновые калоши. Если под руками нет этих предметов, можно обмотать руки шерстяным платком или встать ногами на сухую деревянную доску.

Когда пострадавший освобожден от воздействия тока, ему оказывают помощь, в зависимости от того или иного поражения. При остановке дыхания производят искусственное дыхание, при упадке сердечной деятельности впрыскивают возбуждающее средство — камфору или кофеин. Ожоги лечат обычным путем (см. *Хирургические болезни*).

## ОТРАВЛЕНИЯ

**Общие замечания.** При оказании помощи отравленным следует по мере возможности сначала определить характер яда, вызвавшего отравление. Иногда больной сам не знает, чем он отравился; тогда необходимо тщательно, но в то же время быстро опросить больного или близких ему лиц обо всех обстоятельствах, предшествовавших отравлению, и о всех болезненных проявлениях отравления. Иногда около больного можно найти пузырек с остат-

ками яда. На одежде часто остаются следы принятого яда. По внешнему виду и запаху нередко удается установить природу ядовитого вещества. Нужно обратить внимание на запах выдыхаемого воздуха — запах алкоголя, эфира, хлороформа.

Внешний вид и запах рвотных масс тоже имеют диагностическое значение. Испражнения отравленного (при поносах) — также нужно тщательно осмотреть; ожоги губ, языка, слизистой рта и глотки часто говорят о характере отравления. Затем следует удалить яд из организма или (при невозможности удалить) обезвредить его. Наконец, следует принимать меры для устранения отдельных симптомов, отравления, которые могут быть угрожающими для жизни больного, особенно при поражении нервной системы (паралич дыхательного или сердечно-сосудистого центра), сердца или почек.

**Удаление яда.** При введении яда через кожу или наружные слизистые оболочки в случае их ранения или ожога яд удаляют промыванием большим количеством жидкости (физиологическим раствором, слабыми кислотными или щелочными растворами и др.). Иногда выжигают место проникновения яда или отсасывают его (например, высасывание змеиного яда из ранки). Из желудка яд извлекают промыванием, рвотными средствами или шекотанием глотки вызывают рвоту. Из кишечника удаляют яд сильнодействующими слабительными, лучше всего слабительными: л солями (сернокислая магнезия и сернокислый натрий). Нижний отрезок кишечника промывают высокими клизмами.

Если яд уже всосался в кровь, его следует выводить через выделительные органы и в первую очередь через почки. Отравленным следует давать обильное питье; «если отравленный не пьет или плохо пьет, то делают подкожные, а иногда внутривенные вливания физиологического раствора, а также 5% раствора глюкозы:

Rp. Sol. Natrii chlorati physiologicae 0,85% 600,0  
Sterilisetur! DS. Для подкожного вливания.

Rp. Sol. Glucosae 5% E00,0 Sterilisetur!  
DS. Для подкожного вливания

В экстренных случаях производят кровопускание (400—600 мл) с последующим вливанием указанных растворов; для лучшего выделения мочи назначают мочегонные средства. Для выведения ядовитых веществ путем пототделения назначают горячие ванны с последующим укутыванием, суховоздушные ванны и пр.

**Обезвреживание яда.** Производится путем назначений противоядий. Для адсорбирования (поглощения) ядовитых веществ к промывной воде прибавляют животный уголь, таннип, марганцовокислый калий. Для связывания ядовитого вещества назначают обильное питье молока, белковой воды, яичные белки и пр. При отравлении щелочами назначают . внутрь кислоты и наоборот. Кислота нейтрализует щелочи, а щелочи — кислоту и, таким образом, яд становится безвредным. Некоторые яды имеют и свои